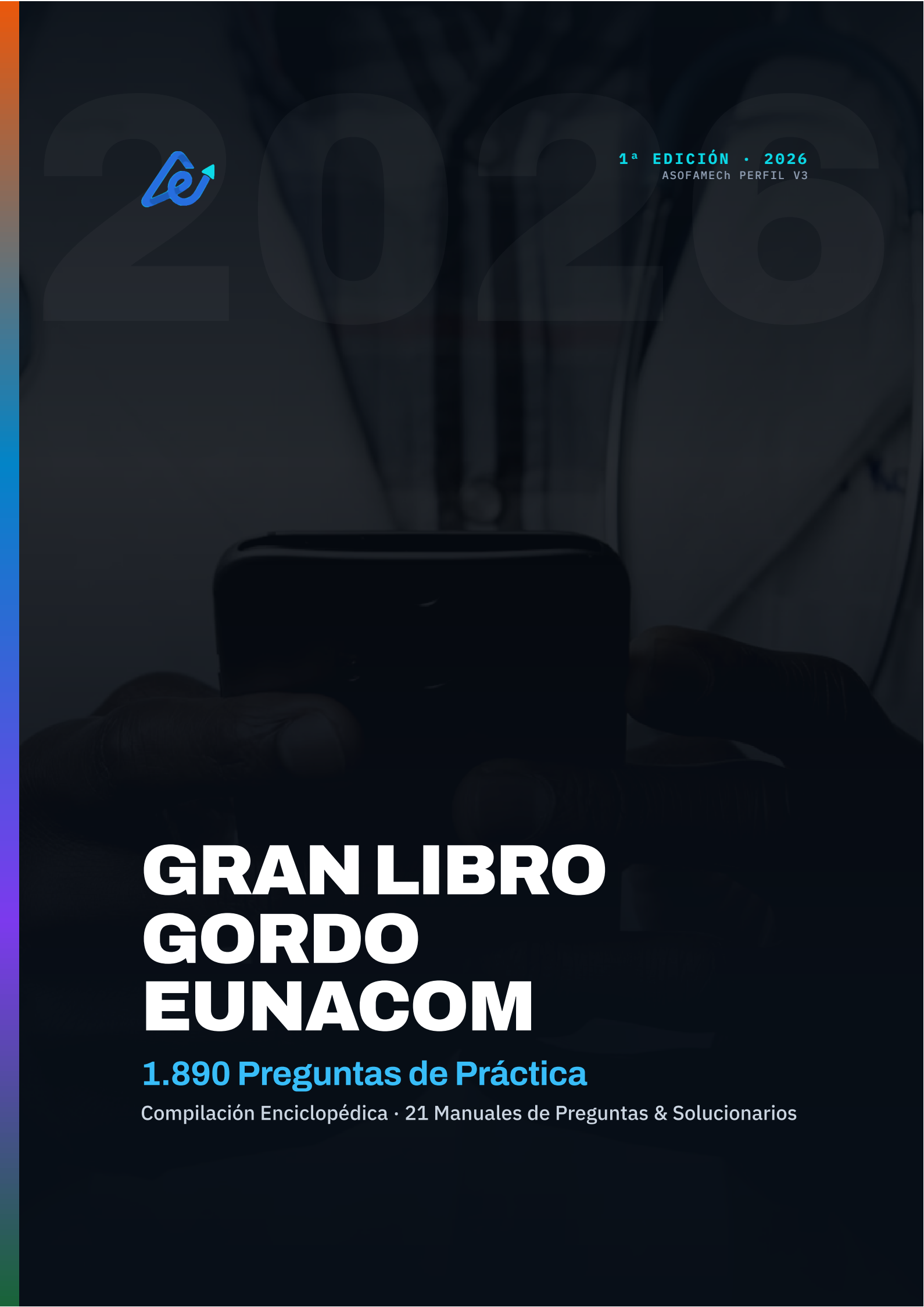


1ª EDICIÓN · 2026
ASOFAMECh PERFIL V3

# GRAN LIBRO GORDO EUNACOM

## 1.890 Preguntas de Práctica

Compilación Enciclopédica · 21 Manuales de Preguntas & Solucionarios

# GRAN LIBRO GORDO EUNACOM

## 1.890 Preguntas de Práctica · Compilación Enciclopédica de 21 Tomos Oficiales


### FICHA TÉCNICA EDITORIAL

| | |
|---|---|
| TÍTULO: | Gran Libro Gordo EUNACOM · 1.890 Preguntas de Práctica |
| AUTORÍA: | Comité Médico Pedagógico de la Academia Examen EUNACOM (AEE) |
| ENTIDAD EDITORA: | **Wiackowska Group SpA** (Santiago de Chile) |
| EDICIÓN: | Primera Edición Oficial · Año 2026 |
| ESTRUCTURA: | 21 Tomos Monográficos · 1.890 Preguntas con Solucionario Razonado |
| ALINEACIÓN: | Perfil de Conocimientos Médicos EUNACOM 2026 (ASOFAMECH / MINSAL) |


### MARCO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR


**AVISO LEGAL Y RESTRICCIÓN DE USO:** Esta obra y su banco integral de preguntas y solucionarios constituyen propiedad intelectual exclusiva de **Wiackowska Group SpA** y la Academia Examen EUNACOM. Queda terminantemente prohibida su venta, reventa, distribución no autorizada, escaneo o difusión pública por cualquier medio físico o digital bajo apercibimiento de las sanciones legales civiles y penales correspondientes.

**Legislación de la República de Chile:** Esta publicación se encuentra registrada y protegida íntegramente por las leyes de la República de Chile, en particular por la **Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual**, sus decretos reglamentarios y los convenios internacionales vigentes ratificados por el Estado de Chile.

**Prohibición Expresa de Reproducción y Venta:** Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación de datos ni transmitida en forma alguna o por cualquier medio —electrónico, mecánico, digital, fotocopia, grabación o cualquier otro— sin la autorización previa, expresa y por escrito de **Wiackowska Group SpA**. Queda prohibida expresamente su comercialización, arriendo, cesión onerosa o gratuita, o su inclusión en bancos de preguntas no autorizados.

**Licencia de Uso Individual y Personal:** El acceso o adquisición de este material otorga únicamente una licencia de uso personal, individual e intransferible a favor del estudiante registrado, destinada exclusivamente a la preparación académica individual para rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).

# GRAN ÍNDICE GENERAL · COLECCIÓN 21 TOMOS

Estructura Curricular Oficial EUNACOM 2026 · 1.890 Preguntas de Práctica

**1ª EDICIÓN AEE · 2013-2026**

| TOMO | ESPECIALIDAD MÉDICA | PREGUNTAS | PERFIL V3 | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|
| **MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA (TOMOS 01 AL 10 · 900 PREGUNTAS)** | | | | |
| **01** | **Cardiología** | 90 Preguntas | 33 Códigos (100%) | Tomo 01 · 23 Clases (71 págs.) |
| **02** | **Infectología** | 90 Preguntas | 39 Códigos (100%) | Tomo 02 · 24 Clases (71 págs.) |
| **03** | **Gastroenterología** | 90 Preguntas | 42 Códigos (100%) | Tomo 03 · 26 Clases (68 págs.) |
| **04** | **Respiratorio / Neumología** | 90 Preguntas | 52 Códigos (100%) | Tomo 04 · 22 Clases (64 págs.) |
| **05** | **Nefrología** | 90 Preguntas | 38 Códigos (100%) | Tomo 05 · 22 Clases (60 págs.) |
| **06** | **Diabetes Mellitus & Nutrición** | 90 Preguntas | 26 Códigos (100%) | Tomo 06 · 18 Clases (52 págs.) |
| **07** | **Endocrinología & Metabolismo** | 90 Preguntas | 28 Códigos (100%) | Tomo 07 · 20 Clases (58 págs.) |
| **08** | **Hematología & Oncología** | 90 Preguntas | 28 Códigos (100%) | Tomo 08 · 20 Clases (58 págs.) |
| **09** | **Reumatología & Inmunología** | 90 Preguntas | 27 Códigos (100%) | Tomo 09 · 18 Clases (54 págs.) |
| **10** | **Neurología & Geriatría** | 90 Preguntas | 50 Códigos (100%) | Tomo 10 · 24 Clases (70 págs.) |
| **MÓDULO 2: CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES (TOMOS 11 AL 17 · 630 PREGUNTAS)** | | | | |
| **11** | **Cirugía General & Anestesia** | 90 Preguntas | 28 Códigos (100%) | Tomo 11 · 20 Clases (62 págs.) |
| **12** | **Traumatología & Ortopedia** | 90 Preguntas | 32 Códigos (100%) | Tomo 12 · 18 Clases (56 págs.) |
| **13** | **Urología** | 90 Preguntas | 22 Códigos (100%) | Tomo 13 · 16 Clases (50 págs.) |
| **14** | **Otorrinolaringología (ORL)** | 90 Preguntas | 27 Códigos (100%) | Tomo 14 · 18 Clases (54 págs.) |
| **15** | **Oftalmología** | 90 Preguntas | 25 Códigos (100%) | Tomo 15 · 16 Clases (50 págs.) |
| **16** | **Dermatología** | 90 Preguntas | 29 Códigos (100%) | Tomo 16 · 18 Clases (54 págs.) |
| **17** | **Psiquiatría General & Salud Mental** | 90 Preguntas | 25 Códigos (100%) | Tomo 17 · 18 Clases (56 págs.) |
| **MÓDULO 3: MATERNO - INFANTIL (TOMOS 18 AL 20 · 270 PREGUNTAS)** | | | | |
| **18** | **Pediatría & Neonatología** | 90 Preguntas | 90 Códigos (100% Urg.) | Tomo 18 · 28 Clases (80 págs.) |
| **19** | **Obstetricia & Materno-Fetal** | 90 Preguntas | 27 Códigos (100%) | Tomo 19 · 22 Clases (68 págs.) |
| **20** | **Ginecología & Oncología** | 90 Preguntas | 26 Códigos (100%) | Tomo 20 · 18 Clases (56 págs.) |
| **MÓDULO 4: SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN (TOMO 21 · 90 PREGUNTAS)** | | | | |
| **21** | **Salud Pública, Bioética & GES** | 90 Preguntas | 31 Códigos (100%) | Tomo 21 · 16 Clases (50 págs.) |

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 01 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# CARDIOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Sistema Cardiovascular

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Cardiología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS** | | | | | |
| 1.01.1.002 | Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16, Q17 | Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.01.1.012 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.013 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8, Q9 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.014 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8, Q10 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.024 | TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.01.2.006 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.2.008 | TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13, Q14 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.01.2.009 | Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16, Q17, Q18 | Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.01.3.001 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.3.002 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.3.004 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.4.001 | Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q1, Q2 | Tomo 01 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 2: CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS** | | | | | |
| 1.01.1.001 | Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 | Tomo 01 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.01.1.008 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33, Q34, Q35 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.1.009 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.1.020 | SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28 | Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.025 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.2.001 | SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20) |
| 1.01.2.002 | SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30, Q31, Q32 | Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22) |
| 1.01.3.003 | SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q31, Q32 | Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22) |
| **BLOQUE 3: INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK** | | | | | |
| 1.01.1.006 | Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q41, Q42 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.01.1.007 | Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.01.1.016 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.017 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q52 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.018 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q53 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.019 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q54 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.2.003 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.004 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.005 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q49 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.007 | Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q43, Q44 | Tomo 01 · 3.3 (Pág. 33) |
| **BLOQUE 4: VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR** | | | | | |
| 1.01.1.002 | Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q55, Q56 | Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.01.1.003 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44) |
| 1.01.1.004 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44) |
| 1.01.1.005 | Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68, Q69 | Tomo 01 · 4.3 (Pág. 46) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.010 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 01 · C.28 (Pág. 60) |
| 1.01.1.011 | Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71, Q72 | Tomo 01 · 4.4 (Pág. 48) |
| 1.01.1.012 | Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71, Q72 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.013 | Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71, Q72 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| **BLOQUE 5: HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO** | | | | | |
| 1.01.1.014 | Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q73, Q74 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.015 | Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 01 · 5.1 (Pág. 53) |
| 1.01.1.021 | Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83, Q84 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.01.1.022 | Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q83, Q84, Q85 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.01.1.023 | Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86, Q87, Q88 | Tomo 01 · 5.4 (Pág. 59) |
| 1.01.1.024 | Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87, Q88 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.01.1.026 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 01 · 5.5 (Pág. 61) |
| 1.01.2.006 | Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.2.008 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Cardiología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.001 | Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 | Tomo 01 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.01.1.002 | Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16, Q17, Q55, Q56 | Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.01.1.003 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44) |
| 1.01.1.004 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44) |
| 1.01.1.005 | Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68, Q69 | Tomo 01 · 4.3 (Pág. 46) |
| 1.01.1.006 | Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q41, Q42 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.01.1.007 | Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.01.1.008 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33, Q34, Q35 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.1.009 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.1.010 | Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 01 · C.28 (Pág. 60) |
| 1.01.1.011 | Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71, Q72 | Tomo 01 · 4.4 (Pág. 48) |
| 1.01.1.012 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q71, Q72 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.013 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8, Q9, Q71, Q72 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.014 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8, Q10, Q73, Q74 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.01.1.015 | Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 01 · 5.1 (Pág. 53) |
| 1.01.1.016 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.017 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q52 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.018 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q53 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.019 | Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q51, Q54 | Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37) |
| 1.01.1.020 | SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28 | Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20) |
| 1.01.1.021 | Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83, Q84 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.01.1.022 | Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q83, Q84, Q85 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.01.1.023 | Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86, Q87, Q88 | Tomo 01 · 5.4 (Pág. 59) |
| 1.01.1.024 | TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q11, Q12, Q13, Q87, Q88 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.01.1.025 | Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35 | Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24) |
| 1.01.1.026 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 01 · 5.5 (Pág. 61) |
| 1.01.2.001 | SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20) |
| 1.01.2.002 | SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30, Q31, Q32 | Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22) |
| 1.01.2.003 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.004 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.005 | Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q49 | Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35) |
| 1.01.2.006 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5, Q80, Q81 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.2.007 | Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q43, Q44 | Tomo 01 · 3.3 (Pág. 33) |
| 1.01.2.008 | TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13, Q14, Q89, Q90 | Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.01.2.009 | Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16, Q17, Q18 | Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.01.3.001 | Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8 | Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.3.002 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.3.003 | SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q31, Q32 | Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22) |
| 1.01.3.004 | Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.01.4.001 | Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q1, Q2 | Tomo 01 · 1.1 (Pág. 5) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS

PREGUNTA 1 — 1.01.4.001

**1. Hombre de 52 años en tratamiento con claritromicina por neumonía presenta palpitaciones y mareos. El ECG revela ritmo sinusal a 75 lpm, intervalo QT medido de 520 ms y RR de 800 ms (QTc calculado de 581 ms mediante fórmula de Bazett). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Suspender de inmediato la claritromicina, monitorizar al paciente y corregir eventuales trastornos hidroelectrolíticos
B) Iniciar Amiodarona endovenosa para prevenir taquiarritmias
C) Indicar cardioversión eléctrica sincronizada
D) Administrar sulfato de atropina 1 mg endovenoso
E) Tranquilizar al paciente e indicar control ambulatorio en 1 semana

PREGUNTA 2 — 1.01.4.001

**2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos descarta la presencia de un ritmo sinusal normal?**

A) Onda P negativa en la derivación DII y positiva en la derivación aVR
B) Frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto
C) Intervalo PR constante de 160 milisegundos
D) Onda P positiva en DI y aVF
E) Complejo QRS precedido por una onda P con intervalo R-R regular

PREGUNTA 3 — 1.01.2.006

**3. Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Desfibrilación inmediata sin RCP previa
B) Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato
E) Acceso venoso y carga de volumen

PREGUNTA 4 — 1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004

**4. Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?**

A) Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación
B) Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea
C) Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal
D) Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa
E) Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

PREGUNTA 5 — 1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004

**5. Hombre de 70 años hospitalizado entra en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra una línea isoeléctrica plana en dos derivaciones con electrodos bien posicionados. ¿Cuál de las siguientes intervenciones está CONTRAINDICADA?**

A) Aplicar una descarga eléctrica de 200 J
B) Administrar Adrenalina 1 mg endovenosa
C) Realizar compresiones torácicas continuas a 100-120 por minuto
D) Ventilar con bolsa-mascarilla conectada a oxígeno
E) Buscar causas reversibles de asistolia

PREGUNTA 6 — 1.01.1.012

**6. Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda "p", de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?**

A) Verapamilo
B) Lanantósido C
C) Losartán
D) Amiodarona
E) Carvedilol

PREGUNTA 7 — 1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001

**7. Mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 acude a control en APS. Se encuentra asintomática. Al examen: pulso irregular a 84 lpm. ECG confirma fibrilación auricular crónica no valvular. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada respecto a la prevención de eventos tromboembólicos?**

A) Iniciar anticoagulación oral permanente con un anticoagulante oral directo (DOAC)
B) Indicar Aspirina 100 mg al día en monoterapia
C) Indicar terapia combinada de Aspirina más Clopidogrel
D) No indicar anticoagulación por encontrarse en frecuencia cardíaca controlada
E) Realizar cardioversión eléctrica ambulatoria inmediata

PREGUNTA 8 1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001

**8. Hombre de 60 años portador de una prótesis valvular mecánica mitral consulta por fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento anticoagulante de elección?**

A) Acenocumarol o Warfarina con meta de INR entre 2.5 y 3.5
B) Apixabán 5 mg cada 12 horas
C) Rivaroxabán 20 mg al día
D) Dabigatrán 150 mg cada 12 horas
E) Heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea indefinida

PREGUNTA 9 1.01.1.013

**9. Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?**

A) Metoprolol oral
B) Amiodarona EV
C) Digoxina EV
D) Flecainida oral
E) Sotalol oral

PREGUNTA 10 1.01.1.014

**10. Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare): El diagnóstico más probable es:**

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

PREGUNTA 11 1.01.1.024

**11. Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen Fsico presenta taquicardia a 170 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y un examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tonos, sin soplos, en la auscultación cardíaca y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, en la auscultación pulmonar. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Verapamilo endovenoso
B) Amiodarona endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

PREGUNTA 12 1.01.1.024, 1.01.2.008

**12. Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?**

A) Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico
B) Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora
C) Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda
D) Digoxina 0.5 mg en infusión lenta
E) Lidocaína 100 mg endovenosa

PREGUNTA 13 1.01.1.024, 1.01.2.008

**13. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos puede desencadenar fibrilación ventricular y paro cardíaco si se administra a un paciente con fibrilación auricular preexcitada (Wolff-Parkinson-White)?**

A) Verapamilo
B) Procainamida
C) Ibutilide
D) Sulfato de Magnesio
E) Quinidina

PREGUNTA 14 1.01.2.008

**14. Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:**

A) Ecocardiograma
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

PREGUNTA 15 1.01.1.002

**15. Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I
C) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II
D) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
E) Enfermedad del nodo sinusal

PREGUNTA 16 1.01.1.002, 1.01.2.009

**16. Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?**

A) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo
B) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria
C) Bloqueo AV de 1er grado; requiere suspender fármacos cronótropos
D) Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica
E) Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

PREGUNTA 17 1.01.1.002, 1.01.2.009

**17. Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra Atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?**

A) Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina
B) Repetir Atropina hasta completar 6 mg
C) Administrar Amiodarona 300 mg endovenosa
D) Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E) Derivar en ambulancia básica sin monitor

PREGUNTA 18 1.01.2.009

**18. Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?**

A) Maniobras vagales
B) Amiodarona endovenosa
C) Adenosina endovenosa
D) Desfibrilación
E) Cardioversión eléctrica

## BLOQUE 2 CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

PREGUNTA 19 1.01.1.001

**19. Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A) Ecocardiograma
B) TAC de tórax
C) Ecocardiografía de esfuerzo
D) Coronariografía
E) Cintigrafía de perfesión miocárdica

PREGUNTA 20 1.01.1.001

**20. Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que aparece al subir dos pisos por escalera y desaparece a los 3 minutos de reposo. El ECG basal es normal. ¿Cuál es la prueba diagnóstica no invasiva de primera línea más adecuada para confirmar isquemia miocárdica y evaluar pronóstico en APS?**

A) Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)
B) Coronariografía invasiva inmediata sin pruebas previas
C) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
D) Determinación seriada de troponinas en reposo
E) Holter de ritmo cardíaco de 24 horas

PREGUNTA 21 1.01.1.001

**21. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha demostrado reducir de forma categórica la mortalidad a largo plazo y la tasa de infarto agudo al miocardio en pacientes portadores de angina crónica estable?**

A) Atorvastatina en dosis de alta potencia (80 mg al día)
B) Nitroglicerina sublingual en esquema fijo tres veces al día
C) Diltiazem oral en monoterapia
D) Mononitrato de Isosorbida 20 mg cada 12 horas
E) Trimetazidina 35 mg cada 12 horas

PREGUNTA 22 1.01.1.001

**22. Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epi- gástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detener- se cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-**

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Cardiopatía hipertensiva

PREGUNTA 23 1.01.1.001

**23. Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus 8po 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la ac8vidad Fsica y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 la8dos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnós8co?**

A) Coronariogra:a
B) Cin2gra:a miocárdica
C) Angiorresonancia de arterias coronarias
D) Test de esfuerzo
E) Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

PREGUNTA 24 1.01.1.001

**24. Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?**

A) Amlodipino
B) Dinitrato de isosorbide
C) Carvedilol
D) Enalapril
E) Hidroclorotiazida

PREGUNTA 25 1.01.1.001

**25. Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a unidad de salud mental
B) Solicitar test de esfuerzo
C) Solicitar troponinas
D) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E) Iniciar anticoagulación oral Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

PREGUNTA 26 1.01.1.020

**26. Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:**

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Síndrome de Brugada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Síncome disautonómico
E) Síndrome de QT largo

PREGUNTA 27 1.01.1.020, 1.01.2.001

**27. Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?**

A) Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea
B) Aspirina 100 mg en monoterapia oral
C) Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato
D) Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios
E) Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

PREGUNTA 28 1.01.1.020, 1.01.2.001

**28. ¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?**

A) Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica
B) Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos
C) Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas
D) Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico
E) Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor

PREGUNTA 29 1.01.2.001

**29. Síndrome adrenérgico por cocaína. Fármaco contraindicado.**

A) Atenolol
B) Captopril
C) Nitroglicerina
D) Diltiazem
E) Amoxicilina

PREGUNTA 30 1.01.2.002

**30. Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pericarditis aguda
B) Disección aórtica
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto agudo al miocardio
E) Embolias cardíacas

PREGUNTA 31 1.01.2.002, 1.01.3.003

**31. Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta médica de elección?**

A) Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal
B) Derivar en ambulancia básica a angioplastía primaria sin trombolisis previa
C) Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas
D) Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto
E) Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

PREGUNTA 32 1.01.2.002, 1.01.3.003

**32. Paciente con infarto agudo al miocardio de pared inferior evoluciona con PA 80/40 mmHg, ingurgitación yugular y examen pulmonar sin ruidos agregados. El ECG muestra supradesnivel del ST de 2 mm en V4R. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para su hipotensión?**

A) Administración rápida de carga de suero fisiológico endovenoso
B) Infusión continua de nitroglicerina
C) Administración de Furosemida 40 mg endovenosa
D) Administración de Morfina 5 mg endovenosa
E) Inicio inmediato de Propanolol oral

PREGUNTA 33 1.01.1.008

**33. Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 34 1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025

**34. Hombre de 62 años en su 5° día post-infarto agudo al miocardio evoluciona con hipotensión severa y disnea. Al examen destaca un soplo pansistólico rudo con frémito en el borde esternal izquierdo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rotura del tabique interventricular (CIV post-IAM)
B) Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
C) Insuficiencia aórtica aguda
D) Reinfarto miocárdico con pericarditis
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 35 1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025

**35. Mujer de 35 años fumadora consulta por dolor torácico opresivo nocturno en reposo. El ECG durante el dolor muestra supradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones anteriores que se normaliza completamente al ceder el dolor con nitroglicerina sublingual. La coronariografía no muestra lesiones obstructivas fijas. ¿Cuál es el fármaco profiláctico de primera línea?**

A) Amlodipino o Diltiazem
B) Propranolol oral
C) Atenolol oral
D) Carvedilol oral
E) Metoprolol succinato

PREGUNTA 36 1.01.1.009

**36. Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis mitral
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

## BLOQUE 3 INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK

PREGUNTA 37 1.01.1.006

**37. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido auscultable en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?**

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

PREGUNTA 38 1.01.1.006, 1.01.1.007

**38. Hombre de 68 años con hipertensión arterial de 20 años de evolución consulta por disnea de esfuerzos progresiva y ortopnea de 2 semanas. Al examen físico destaca ingurgitación yugular, ritmo de galope con tercer ruido auscultable en el ápex y crépitos basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable según los criterios de Framingham?**

A) Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada
B) Crisis de asma bronquial del adulto
C) Tromboembolismo pulmonar crónico
D) Neumonía bacteriana multilobar
E) Estenosis traqueal extrínseca

PREGUNTA 39 1.01.1.006, 1.01.1.007

**39. En un paciente de 75 años que consulta en el servicio de urgencia por disnea súbita, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio posee el mayor valor predictivo negativo para descartar origen cardiogénico?**

A) Péptido natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP)
B) Troponina ultrasensible en muestra única
C) Dímero D plasmático
D) Gases arteriales basales
E) Proteína C Reactiva ultrasensible

PREGUNTA 40 1.01.1.007

**40. Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros sín- tomas. Al examen físico tiene temeratura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

A) Ecocardiografía bidimensional
B) Resonancia magnética cardiaca
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) TAC de tórax abdomen y pelvis

PREGUNTA 41 1.01.1.006, 1.01.1.007

**41. Hombre de 62 años con IC-FEr (FEVI 32%) en tratamiento con Enalapril 20 mg/día y Carvedilol 25 mg c/12h. El médico decide cambiar el IECA por Sacubitrilo/Valsartán. ¿Cuál es la indicación farmacológica crítica que debe darse al paciente?**

A) Suspender el Enalapril y esperar al menos 36 horas antes de tomar la primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán
B) Tomar ambos fármacos simultáneamente durante la primera semana
C) Suspender el Carvedilol de forma permanente
D) Asociar Espironolactona en dosis de 100 mg antes de hacer el cambio
E) Realizar el cambio directo sin ningún período de espera

PREGUNTA 42 1.01.1.006, 1.01.1.007

**42. ¿Cuál de los siguientes fármacos para la insuficiencia cardíaca alivia rápidamente los síntomas congestivos pero NO ha demostrado reducir la mortalidad a largo plazo en pacientes con IC-FEr?**

A) Furosemida
B) Empagliflozina
C) Carvedilol
D) Espironolactona
E) Sacubitrilo / Valsartán

PREGUNTA 43 1.01.2.007

**43. Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria no farmacológica de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?**

A) Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)
B) Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto
C) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva inmediata
D) Nebulización continua con Salbutamol
E) Aspiración traqueal a circuito abierto

PREGUNTA 44 1.01.2.007

**44. ¿Cuál es el vasodilatador endovenoso de elección para el manejo agudo de un paciente con edema pulmonar cardiogénico con presión arterial de 190/100 mmHg?**

A) Nitroglicerina en infusión continua endovenosa
B) Nifedipino sublingual en cápsula
C) Nitroprusiato de sodio asociado a betabloqueadores
D) Hidralazina intramuscular
E) Atenolol endovenoso en bolo

PREGUNTA 45 1.01.2.003

**45. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?**

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

PREGUNTA 46 1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005

**46. Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?**

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

PREGUNTA 47 1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005

**47. Un paciente en shock presenta mediante monitoreo hemodinámico: Gasto Cardíaco aumentado, Resistencia Vascular Sistémica disminuida y Presión Capilar Pulmonar baja. ¿Cuál es el tipo de shock?**

A) Shock distributivo / séptico
B) Shock cardiogénico
C) Shock hipovolémico
D) Shock obstructivo por taponamiento
E) Shock obstructivo por TEP masivo

PREGUNTA 48 1.01.2.004

**48. Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Pre- senta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:**

A) Tratamiento anticoagulante
B) Tratamiento antiplaquetario
C) Solicitar AngioTAC de tórax
D) Ecocardiograma bidimensional
E) Coronariografía de urgencia

PREGUNTA 49 1.01.2.005

**49. (88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:**

A) SCA
B) Disección aórtica
C) NAC
D) IC aguda
E) TEP f. Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico.

PREGUNTA 50 1.01.1.016

**50.** **Paciente con HTA en tratamiento triple (enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida) con presiones elevadas persistentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar dosis de enalapril al máximo
B) Agregar beta-bloqueador oral
C) Suspender hidroclorotiazida y agregar furosemida
D) Derivar a nefrología de urgencia
E) Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

PREGUNTA 51 1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019

**51.** **Atleta de 20 años asintomático es evaluado en control deportivo. Se ausculta un soplo sistólico eyectivo en borde esternal izquierdo que AUMENTA de intensidad al ponerse de pie e inclinarse y DISMINUYE al colocarse en cuclillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
B) Estenosis aórtica degenerativa
C) Insuficiencia mitral reumática
D) Comunicación interauricular
E) Estenosis pulmonar congénita

PREGUNTA 52 1.01.1.017

**52.** **Pregunta 71 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:**

A) Insuficiencia tricuspídea
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis mitral
E) Insuficiencia mitral

PREGUNTA 53 1.01.1.018

**53.** **Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día, furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 65x', presión arterial: 110/70 mmHg, saturación de oxígeno del 96%; en el examen cardiopulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta es palpable en la línea axilar media y presenta edema en los miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?**

A) Agregar losartán
B) Agregar hidralazina
C) Agregar isosorbide
D) Agregar espironolactona
E) Agregar amiodarona

PREGUNTA 54 1.01.1.019

**54.** **Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumá8ca en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen Fsico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 la8dos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia aór2ca
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aór2ca
E) Ductus arterioso persistente

## BLOQUE 4 VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR

PREGUNTA 55 1.01.1.002

**55.** **Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0.8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?**

A) Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico
B) Tratamiento médico exclusivo con Betabloqueadores y control anual
C) Iniciar Enalapril y Nitratos en dosis crecientes
D) Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo
E) Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

PREGUNTA 56 1.01.1.002

**56.** **¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en un paciente de 45 años sin antecedentes de fiebre reumática?**

A) Válvula aórtica bicúspide congénita
B) Degeneración fibrocalcárea senil
C) Endocarditis infecciosa por enterococo
D) Aterosclerosis de la raíz aórtica
E) Lupus eritematoso sistémico (Libman-Sacks)

PREGUNTA 57 1.01.1.003

**57.** **Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?**

A) Recoartación aórtica
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Disección aórtica

PREGUNTA 58 1.01.1.003

**58.** **Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tetralogía de Fallot
B) Ductus arterioso persistente
C) Estenosis pulmonar
D) Comunicación interauricular (CIA)
E) Comunicación interventricular

PREGUNTA 59 1.01.1.003

**59.** **Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

PREGUNTA 60 1.01.1.003

**60.** **Pregunta 32 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:**

A) Comunicación interauricular
B) Dustus arterioso persistente
C) Estenosis aórtica
D) Comunicación interventricular
E) Insuficiencia aórtica

PREGUNTA 61 1.01.1.003

**61.** **Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis pulmonar

PREGUNTA 62 1.01.1.003

**62.** **Un paciente de 30 años presneta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:**

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Tetralogía de Fallot
E) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

PREGUNTA 63 1.01.1.003, 1.01.1.004

**63.** **Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso súbito (pulso céler) y oscilación de la cabeza rítmica con el pulso (signo de Musset). ¿Cuál es la valvulopatía causante?**

A) Insuficiencia aórtica severa
B) Estenosis aórtica severa
C) Insuficiencia mitral severa
D) Estenosis pulmonar
E) Coartación aórtica

PREGUNTA 64 1.01.1.003, 1.01.1.004

**64.** **¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1 cm²), valvas móviles sin calcificación y Score de Wilkins de 6 puntos?**

A) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C) Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D) Tratamiento exclusivo con Furosemida oral
E) Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

PREGUNTA 65 1.01.1.004

**65.** **Un paciente de 76 años, fumador de 80 paquetes-año, con EPOC severo en tratamiento con budesonida y salmeterol inhalados, presenta aumento de su disnea e intolerancia al ejercicio desde hace 7 días, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 110/70 mmHg e ingurgitación yugular a 45°. Se ausculta ritmo regular en dos tonos con ruidos apagados y murmullo pulmonar disminuido de manera bilateral, con roncus y sibilancias difusos. Se solicita ecocardiograma que muestra cavidades izquierdas con leve dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección conservada de 58%, y cavidades derechas dilatadas con paredes hipertróficas, con es8mación de presión de arteria pulmonar de 68 mmHg. Su radiograFa de tórax se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Hipertensión pulmonar primaria
B) Insuficiencia cardíaca conges2va
C) Exacerbación de enfermedad pulmonar obstruc2va crónica
D) Cor pulmonale descompensado
E) Tromboembolismo pulmonar

PREGUNTA 66 1.01.1.010

**66.** **Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis pulmonar
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Insuficiencia pulmonar

PREGUNTA 67 1.01.1.005

**67.** **Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?**

A) Atorvastatina
B) Gemfibrozilo
C) Insulina
D) Lovastatina más gemfibrozilo
E) Ezetimibe

PREGUNTA 68 1.01.1.005

**68.** **Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?**

A) El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B) El soplo desaparece por completo
C) El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D) No se produce ninguna modificación auscultatoria
E) Aparece un cuarto ruido cardíaco

PREGUNTA 69 1.01.1.005

**69.** **¿Cuál es la intervención quirúrgica de elección en un paciente con insuficiencia mitral primaria severa por rotura degenerativa de cuerdas tendinosas y FEVI del 55%?**

A) Cirugía de reparación valvular (Plastía Mitral)
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica
C) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
D) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
E) Cierre percutáneo de la comunicación interventricular

PREGUNTA 70 1.01.1.011

**70.** **Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

PREGUNTA 71 1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013

**71.** **Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

PREGUNTA 72 1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013

**72.** **Hombre de 25 años en estudio por hipertensión arterial de difícil manejo. Al examen se pesquisan pulsos femorales marcadamente disminuidos en comparación con los radiales. La radiografía de tórax muestra erosiones óseas en el borde inferior de las costillas. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Coartación aórtica
B) Feocromocitoma bilateral
C) Hiperaldosteronismo primario
D) Enfermedad de Takayasu
E) Estenosis de arteria renal aterosclerótica

PREGUNTA 73 1.01.1.014, 1.01.1.015

**73. Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa elevación de la Creatinina plasmática desde 1.0 mg/dL basal hasta 2.4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B) Hiperaldosteronismo primario (Conn)
C) Nefropatía diabética incipiente
D) Glomerulonefritis membranosa
E) Necrosis tubular aguda tóxica

PREGUNTA 74 1.01.1.014, 1.01.1.015

**74. Mujer de 38 años consulta por crisis paroxísticas de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones rápidas y sudoración profusa generalizada. Durante la consulta se registra PA de 210/120 mmHg y FC de 115 lpm. ¿Cuál es el examen de primera elección para el diagnóstico de esta condición?**

A) Determinación de metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina de 24 horas
B) Cortisol libre urinario en 24 horas
C) Relación aldosterona / renina plasmática
D) Ecocardiograma transesofágico
E) Resonancia magnética de cerebro y fosa posterior

PREGUNTA 75 1.01.1.015

**75. Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C) Agregar atenolol 12,5 mg/día
D) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E) Mantener el tratamienti

PREGUNTA 76 1.01.1.015

**76. Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, obje8vándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múl8ples registros sobre 140/90 mmHg, diagnos8cándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmá8cos y electrocardiograma. ¿Qué 8po de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento an8hipertensivo en este paciente?**

A) Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B) Bloqueadores beta-adrenérgicos
C) Inhibidores del canal de calcio
D) Antagonistas del receptor de angiotensina
E) Diuré2cos 2azídicos

PREGUNTA 77 1.01.1.015

**77. Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B) Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C) Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D) Atenolol (agregar betabloqueador)
E) Suspender enalapril sin reemplazar

PREGUNTA 78 1.01.1.015

**78. Paciente con HTA en triple terapia (IECA, amlodipino, HCTZ), con edema en extremidades inferiores y presión 120/70. ¿Cuál es la conducta?**

A) Agregar furosemida oral
B) Suspender amlodipino
C) Reducir dosis de IECA
D) Agregar espironolactona
E) Derivar a cardiología por insuficiencia cardíaca

PREGUNTA 79 1.01.1.015

**79. Paciente con HTA sobre el rango normal en tratamiento actual, ¿cuál es el medicamento más adecuado a agregar?**

A) Amlodipino
B) Valsartán (ARA II)
C) Hidroclorotiazida
D) Carvedilol
E) Furosemida

PREGUNTA 80 1.01.2.006

**80. Hombre de 62 años consulta por cefalea leve sin otros síntomas. PA 210/115 mmHg. Examen físico neurológico, cardíaco y fondo de ojo completamente normales. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada?**

A) Indicar reposo y administrar antihipertensivo oral con control en 24-48 horas
B) Hospitalizar de inmediato en UCI e iniciar Nitroprusiato de sodio endovenoso
C) Administrar una cápsula de Nifedipino sublingual perforada
D) Realizar punción lumbar de urgencia para descartar hemorragia
E) Administrar Furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 4 horas

PREGUNTA 81 1.01.2.006

**81. Paciente con Disección Aórtica aguda tipo A se presenta con PA 220/120 mmHg y FC 110 lpm. ¿Cuál es el objetivo hemodinámico y el tratamiento inicial de elección antes de ingresar a pabellón?**

A) Labetalol endovenoso para alcanzar PAS < 120 mmHg y FC < 60 lpm en menos de 20 minutos
B) Nitroprusiato de sodio en monoterapia para bajar la PAM un 10% en 24 horas
C) Hidralazina endovenosa para mantener PAS alrededor de 160 mmHg
D) Furosemida endovenosa en bolo y reposo absoluto
E) Enalapril oral cada 8 horas hasta normalizar la presión

PREGUNTA 82 1.01.1.021

**82. Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela, con infecciones respiratorias recurrentes. Signos vitales normales, auscultación pulmonar normal. A la auscultación cardiaca se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. Talla -1 DE para su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

PREGUNTA 83 1.01.1.021, 1.01.1.022

**83. Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva a largo plazo?**

A) Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses
B) Prednisona en dosis altas en monoterapia
C) Antibioticoterapia empírica con Ceftriaxona endovenosa
D) Anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular
E) Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

PREGUNTA 84 1.01.1.021, 1.01.1.022

**84. Mujer de 55 años con cáncer pulmonar consulta por disnea severa y decaimiento. Al examen: PA 85/50 mmHg, ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular, ruidos cardíacos muy apagados y una caída de 18 mmHg de la presión arterial sistólica durante la inspiración. ¿Cuál es el procedimiento de urgencia indicado?**

A) Pericardiocentesis evacuadora de urgencia
B) Administración de Furosemida 80 mg endovenosa
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Instalación de marcapaso transitorio
E) Infusión de Nitroglicerina a dosis altas

PREGUNTA 85 1.01.1.022

**85. Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 8 (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86115). El diagnóstico más probable es:**

A) Pericarditis aguda
B) Espasmo esofágico
C) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
D) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
E) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral

PREGUNTA 86 1.01.1.023

**86. Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?**

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

PREGUNTA 87 1.01.1.023, 1.01.1.024

**87. Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?**

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

PREGUNTA 88 1.01.1.023, 1.01.1.024

**88. Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal de 5.8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?**

A) Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)
B) Control ecográfico anual para vigilar crecimiento
C) Iniciar anticoagulación oral con Warfarina
D) Indicar reposo en cama permanente
E) Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

PREGUNTA 89 1.01.1.026, 1.01.2.008

**89.** **Mujer de 68 años con antecedente de reemplazo total de cadera hace 10 días presenta disnea súbita y taquicardia de 115 lpm. El cálculo del Score de Wells arroja 7 puntos (probabilidad alta). ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

**A)** Solicitar AngioTAC de arterias pulmonares con contraste endovenoso

**B)** Solicitar Dímero D plasmático por técnica ELISA

**C)** Tomar radiografía de tórax y si es normal descartar el cuadro

**D)** Solicitar ecocardiograma transtorácico ambulatorio

**E)** Realizar prueba de esfuerzo convencional

PREGUNTA 90 1.01.1.026, 1.01.2.008

**90.** **Hombre de 54 años con TEP confirmado evoluciona bruscamente con PA de 70/40 mmHg, frialdad distal y signos de shock obstructivo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea que debe indicarse de inmediato?**

**A)** Fibrinólisis sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg endovenoso)

**B)** Anticoagulación exclusiva con Apixabán oral

**C)** Instalación de filtro de vena cava inferior

**D)** Infusión de nitroglicerina a dosis crecientes

**E)** Administración de Furosemida 80 mg endovenosa

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ARRITMIAS, CONDUCCIÓN & URGENCIAS ELÉCTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

1.01.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS**

Un QTc > 500 ms representa un riesgo crítico de inducir Torsades de Pointes y fibrilación ventricular. La medida mandatoria es suspender inmediatamente el fármaco causante (los macrólidos como la claritromicina prolongan el QT), monitorizar el ritmo cardíaco y asegurar niveles plasmáticos normales de potasio y magnesio. La amiodarona prolongaría aún más el QT y está contraindicada.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A

1.01.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS**

En el ritmo sinusal normal, la despolarización auricular se origina en el nodo sinusal (ubicado en la parte alta de la aurícula derecha) y se dirige hacia abajo y a la izquierda. Por ende, la onda P DEBE ser positiva en DII, DIII y aVF, y negativa en aVR. Una onda P negativa en DII indica un ritmo auricular bajo o ectópico.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL**

Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL**

La regla de oro del ACLS establece que inmediatamente después de administrar una descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas durante 2 minutos completos sin interrumpir para verificar el ritmo o el pulso. Chequear el pulso inmediatamente después del choque genera pausas innecesarias y el corazón recién desfibrilado requiere soporte hemodinámico mediante compresiones para recuperar el gasto cardíaco.

### PREGUNTA 5 Respuesta: A

1.01.2.006, 1.01.3.002, 1.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL**

La asistolia es un ritmo no desfibrilable. La aplicación de descargas eléctricas en asistolia no tiene utilidad fisiológica, produce daño térmico miocárdico adicional y retrasa las compresiones torácicas efectivas, por lo que está formalmente contraindicada.

### PREGUNTA 6 Respuesta: E

1.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)**

Los betabloqueantes empeoran el EPOC (que se trata con beta-agonistas).

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A**

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)**

La paciente presenta un puntaje $CHA_2DS_2$-VASc de 5 (Edad ≥ 75: 2 pts, HTA: 1 pt, DM: 1 pt, Sexo femenino: 1 pt), lo que confiere un riesgo tromboembólico anual > 6-8%. La indicación obligatoria según guías MINSAL y protocolos GES es la Anticoagulación Oral continua con DOACs (Apixabán, Rivaroxabán o Dabigatrán). La aspirina no previene el ACV embólico y no debe utilizarse.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: A**

1.01.1.012, 1.01.1.013, 1.01.1.014, 1.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)**

Las prótesis valvulares cardíacas mecánicas constituyen una contraindicación absoluta para el uso de DOACs (ensayos clínicos demostraron mayor tasa de trombosis protésica y sangrado con dabigatrán/rivaroxabán). El único tratamiento anticoagulante validado y seguro son los antagonistas de vitamina K (Acenocumarol/Warfarina) con meta de INR estricta de 2.5 a 3.5 para válvulas mecánicas mitrales.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)**

FA con respuesta ventricular rápida estable y FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol) o calcioantagonista (diltiazem/verapamilo). Metoprolol es primera línea.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: C**

1.01.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)**

En las últimas dos derivaciones se ven claramente las ondas de serrucho (que aparecen con la maniobra vagal, ya que bradicardiza y aumenta el bloqueo AV), características del flutter.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: D**

1.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

Tiene una TPSV clásica. El tratamiento de primera línea son las maniobras vagales (ej. Valsalva modificado es la más recomendada en adultos y niños que cooperan; en niños pequeño se prefiere la inmersión facial en agua fría. El masaje caroVdeo se puede usar en adultos, pero no se recomienda en niños ni en adultos mayores con riesgo de ateroma caroVdeo que se pueda soltar). De segunda línea se uGlizan fármacos, siendo de elección la adenosina en bolo EV de 6 mg. Si falla, se dan hasta dos nuevas dosis de 12 mg. Si vuelve a fallar, se usa el verapamilo (contraindicado en falla cardíaca e hipotensión). Como toda taquiarritmia, si está hemodinámicamente inestable, de primera línea se maneja con cardioversión eléctrica.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

1.01.1.024, 1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

La Adenosina tiene una vida media ultracorta (< 10 segundos). Para que alcance concentraciones terapéuticas en el nodo AV, debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 segundos) en una vena periférica proximal, seguido de un bolo de lavado de 20 mL de solución fisiológica y elevación del brazo. La dosis inicial es de 6 mg.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: A**

1.01.1.024, 1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

El Verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínico que bloquea la conducción en el nodo auriculoventricular sin afectar la vía accesoria. Al suprimir el freno nodal, los impulsos auriculares caóticos pasan sin resistencia por la vía accesoria rápida hacia los ventrículos, gatillando Fibrilación Ventricular.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 158). Evalúa el manejo clínico de Taponamiento pericárdico según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: D**

1.01.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)**

Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: A**

1.01.1.002, 1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)**

El bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del intervalo PR define un Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II. Debido a que la lesión se encuentra en el sistema His-Purkinje infranodal, existe un alto riesgo de progresión a bloqueo completo y muerte súbita, por lo que tiene indicación formal de Marcapaso Definitivo.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

1.01.1.002, 1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)**

En una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica que no responde a la dosis inicial de atropina, la conducta de emergencia perentoria es la estimulación eléctrica mediante marcapaso transcutáneo externo asociada al inicio de drogas vasoactivas (Adrenalina o Dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: E**

1.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)**

Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).

---

## BLOQUE 2 CARDIOPATÍA CORONARIA & SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

En un paciente con sospecha de angina crónica estable, capaz de realizar ejercicio físico y con un ECG basal normal e interpretable, la prueba no invasiva de primera elección recomendada por el MINSAL y consensos internacionales es el Test de Esfuerzo Convencional (Ergometría). Permite confirmar la presencia de isquemia miocárdica inducible, cuantificar el umbral isquémico en METs y estratificar el riesgo cardiovascular global.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

Las estatinas de alta potencia (Atorvastatina 40-80 mg/día o Rosuvastatina 20-40 mg/día) y la Aspirina son los dos pilares farmacológicos que han demostrado modificar la historia natural de la cardiopatía coronaria, estabilizando las placas de ateroma y reduciendo significativamente la mortalidad cardiovascular. Los nitratos, calcioantagonistas y trimetazidina son fármacos antianginosos sintomáticos que mejoran la tolerancia al esfuerzo pero no modifican la sobrevida.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: D**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

Es una angina crónica estable. Su diagnóstico es clínico y su estudio comienza con una prueba de esfuerzo, generalmente el ECG de esfuerzo. En los casos en que no se puede realizar (amputados o pacientes que no toleran el ejercicio) y en los casos en que el electrocardiograma es ilegible (ej. BCRI), se uGlizan otras pruebas de esfuerzo, como la ecocardiografía, con dobutamina o la cintigrafía cardiaca con talio y dipiridamol. Si alguna de estas pruebas de esfuerzo resulta alterada, se procede a la coronariografía para determinar la vía de revascularización. La regla general es que se uGlice un stent cuando hay compromiso de uno o dos vasos, y se uGlice un bypass coronario cuando hay compromiso de tres vasos o de dos vasos incluyendo la arteria descendente anterior (ADA).

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastía o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional**

Caso clínico oficial EUNACOM para Angina crónica estable.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: C**

1.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST**

Es una miocardiopatía hipertrófica clásica (síncope, antecedentes de muerte súbita en la familia, soplo eyectivo y clínica de insuficiencia cardiaca). Veremos en detalle toda la semiología cardíaca.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

1.01.1.020, 1.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST**

El pilar farmacológico del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación plaquetaria (Aspirina + Ticagrelor) asociada a anticoagulación parenteral (Enoxaparina). La trombólisis farmacológica está formalmente CONTRAINDICADA en el SCASEST (solo se usa en SCACEST con supradesnivel del ST).

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

1.01.1.020, 1.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST**

La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para pacientes con criterios de muy alto riesgo isquémico o inestabilidad: shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos/analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: A**

1.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 43). Evalúa el manejo clínico de Angina inestable según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

1.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98). Evalúa el manejo clínico de Disección aórtica según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: A**

1.01.2.002, 1.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES**

Cuando el tiempo para realizar una angioplastía primaria supera los 120 minutos, la guía GES y las normas internacionales obligan a realizar fibrinólisis farmacológica inmediata con Tenecteplase en menos de 30 minutos desde el ingreso para salvar miocardio y reducir la mortalidad.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

1.01.2.002, 1.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES**

El paciente presenta un infarto del ventrículo derecho confirmado por V4R positivo. El ventrículo derecho infartado se vuelve rígido y depende críticamente de una presión de llenado elevada (precarga) para mantener el gasto cardíaco. El tratamiento de elección de la hipotensión es la expansión volumétrica agresiva con suero fisiológico. Los nitratos y diuréticos reducen la precarga y causan colapso circulatorio irreversible.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: A**

1.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal**

La presencia de un soplo pansistólico rudo en el borde esternal izquierdo bajo asociado a un frémito palpable (sensación táctil de turbulencia) tras varios días de un infarto es patognomónica de la Rotura del Tabique Interventricular.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: A**

1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal**

La presencia de un soplo pansistólico rudo en el borde esternal izquierdo bajo asociado a un frémito palpable (sensación táctil de turbulencia) tras varios días de un infarto es patognomónica de la Rotura del Tabique Interventricular.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: A**

1.01.1.008, 1.01.1.009, 1.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal**

El cuadro clínico corresponde a una Angina Vasoespástica (Angina de Prinzmetal). Los fármacos de primera línea para prevenir nuevos episodios son los antagonistas del calcio (Amlodipino, Diltiazem o Verapamilo). Los betabloqueadores están estrictamente contraindicados.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

**Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal**

1.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

## BLOQUE 3 INSUFICIENCIA CARDÍACA, MIOCARDIOPATÍAS & SHOCK · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta 4 criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por R3 y crépitos pulmonares bilaterales), lo que confirma con certeza absoluta el diagnóstico clínico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham**

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta 4 criterios mayores de Framingham (ortopnea, ingurgitación yugular, galope por R3 y crépitos pulmonares bilaterales), lo que confirma con certeza absoluta el diagnóstico clínico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham**

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Los péptidos natriuréticos (BNP < 100 pg/mL o NT-proBNP < 300 pg/mL) poseen un valor predictivo negativo superior al 98%: un valor normal descarta la insuficiencia cardíaca descompensada como causa de la disnea en el servicio de urgencia.

**PREGUNTA 40** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham**

1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

**Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)**

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La inhibición simultánea de la ECA y de la neprilisina produce una acumulación masiva de bradicinina que puede desencadenar un angioedema orofaríngeo fatal. Por ende, se exige un período de lavado de al menos 36 horas tras la última dosis de IECA antes de iniciar Sacubitrilo/Valsartán.

**PREGUNTA 42** **Respuesta: A**

**Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)**

1.01.1.006, 1.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La Furosemida es un diurético de asa sintomático esencial para aliviar la sobrecarga de volumen y edemas, pero no modifica la historia natural ni disminuye la mortalidad. Los 4 fármacos que sí reducen mortalidad son: ARNI, Betabloqueadores, ARM e iSGLT2.

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Ventilación No Invasiva (VNI) en modalidad CPAP es la medida más costo-efectiva y de primera línea en el edema agudo de pulmón cardiogénico: recluta alvéolos inundados de líquido, mejora la oxigenación y reduce la precarga y poscarga, disminuyendo drásticamente la tasa de intubación endotraqueal.

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A**

**Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La nitroglicerina endovenosa es el vasodilatador de primera línea: produce venodilatación potente a dosis bajas (reduciendo la precarga) y vasodilatación arterial a dosis más altas (reduciendo la poscarga), aliviando de forma casi inmediata la congestión pulmonar.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks**

1.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A**

**Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks**

1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: A**

**Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks**

1.01.2.003, 1.01.2.004, 1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El patrón hemodinámico caracterizado por Gasto Cardíaco elevado (fase hiperdinámica) con Resistencia Vascular Sistémica baja (vasoplejía periférica por mediadores inflamatorios) es exclusivo del Shock Distributivo (Séptico, Anafiláctico o Neurogénico).

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: E**

**Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks**

1.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastía de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: D**

**Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks**

1.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88). Evalúa el manejo clínico de Insuficiencia cardíaca aguda según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: E**

**Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)**

1.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)**

1.01.1.016, 1.01.1.017, 1.01.1.018, 1.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El soplo de la Miocardiopatía Hipertrófica es el único soplo sistólico eyectivo (junto al prolapso mitral) que aumenta de intensidad con maniobras que reducen el llenado ventricular (Valsalva o ponerse de pie) y disminuye con maniobras que aumentan el volumen ventricular (cuclillas o handgrip).

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: C**

**Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)**

1.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una insuficiencia aórtica clásica.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: D**

**Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)**

1.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Insuficiencia Cardíaca Congestiva: Los medicamentos que aumentan la supervivencia en la insuficiencia cardíaca congestiva son los IECA o ARA II, betabloqueantes (idealmente carvedilol) y espironolactona. El manejo de la patología de base también es fundamental. El losartán no se usa en este caso porque el paciente ya toma enalapril, que cumple la misma función.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)**

1.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una insuficiencia mitral clásica, con clínica de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea y crépitos), soplo holosistólico y desplazamiento del choque de la punta, que sugiere cardiomegalia. Revisar resumen de semiología cardiaca.

---

## BLOQUE 4 VALVULOPATÍAS & SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A**

**Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)**

1.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El paciente tiene una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (AVA < 1.0 cm² y gradiente > 40 mmHg). La aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular (TAVI en ancianos o cirugía en jóvenes) para evitar la muerte súbita y mejorar el pronóstico.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)**

1.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En pacientes menores de 65 años, la causa más frecuente de estenosis aórtica aislada es la calcificación acelerada sobre una válvula aórtica bicúspide congénita. En mayores de 70 años predomina la calcificación senil degenerativa.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 3). Evalúa el manejo clínico de Cardiopatía congénita en adulto según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: D**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

CIA: soplo sistólico de eyección en foco pulmonar (por hiperflujo pulmonar) + desdoblamiento FIJO del S2 (por sobrecarga de volumen en VD independiente de la respiración) = signo casi patognomónico de CIA. Suele diagnosticarse en embarazo por el aumento del gasto cardíaco.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003, 1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La presión diferencial sumamente amplia (170/45 mmHg) asociada al pulso saltón o de Corrigan y a signos periféricos hiperdinámicos (Musset, Quincke) es patognomónica de la Insuficiencia Aórtica Crónica Severa.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.003, 1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En la estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable definida por un Score de Wilkins ≤ 8 puntos (valvas móviles, poco engrosadas y sin calcificación comisural severa ni insuficiencia mitral significativa), la Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón es el tratamiento de primera elección por su alta eficacia y mínima invasividad.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: D**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca derecha: astenia, edema, yugulares ingurgitadas. En el ecocardiograma se confirma la hipertrofia derecha y la hipertensión pulmonar (PAP > 25 mmHg), que no es primaria, sino secundaria al EPOC. Por tanto, es un cor pulmonar clásico. No Gene una insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), que se refiere a la ICC izquierda, con tendencia al edema pulmonar. La radiografía muestra campos pulmonares grandes, con corazón en gota, clásico del EPOC avanzado. Fuente imagen: hxps://li~l.com/.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

**Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática**

1.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)**

1.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El LDL es la prioridad (a menos que los triglicéridos estén mayores a 500). Las estatinas están indicadas de inmediato cuando el LDL es mayor a 190 en pacientes de bajo riesgo CV o cuando es mayor a 100 en los diabéticos. Además cuando continúa alto el LDL, a pesar de 3 meses con dieta. Los médicos generales no deben indicar estatinas y gemfibrozilo juntos.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)**

1.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo se reduce. En un ventrículo más pequeño, las valvas mitrales redundantes prolapsan antes durante la eyección sistólica, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)**

1.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En la insuficiencia mitral orgánica degenerativa, la Plastía Mitral (reparación de valvas y cuerdas con anillo de anuloplastía) es la técnica de elección superior al reemplazo protésico, ya que preserva la geometría y contractilidad del ventrículo izquierdo y evita la anticoagulación crónica de por vida.

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

**Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto**

1.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

**Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto**

1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto**

1.01.1.011, 1.01.1.012, 1.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Coartación Aórtica se presenta típicamente como hipertensión arterial en pacientes jóvenes con marcada asimetría de pulsos (braquiales fuertes vs femorales débiles) y signo radiológico de Roesler (muescas costales por dilatación de arterias intercostales colaterales).

## BLOQUE 5 HTA, PATOLOGÍA VASCULAR & PERICARDIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A**

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

1.01.1.014, 1.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El deterioro brusco de la función renal (alza de creatinina > 30-50%) tras la introducción de un IECA o ARA2, sumado a la auscultación de un soplo abdominal en el flanco, es patognomónico de la Estenosis Bilateral de la Arteria Renal o unilateral en riñón único, al eliminarse la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por angiotensina II.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A**

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

1.01.1.014, 1.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La tríada clásica de cefalea + sudoración + palpitaciones con crisis hipertensivas paroxísticas es altamente específica de Feocromocitoma. El método de tamizaje de primera elección con mayor sensibilidad (> 97%) es la cuantificación de metanefrinas plasmáticas u urinarias.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: E**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: D**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

Además de obesidad, con alta probabilidad Gene una hipertensión esencial, ya que no Gene elementos que hagan sospechar una causa secundaria. En pacientes jóvenes se suele iniciar con IECA (inhibidores de la enzima converGdora de angiotensina) o ARA2 (antagonistas del receptor de angiotensina 2). Muchas guías actuales prefieren iniciar con dos fármacos de forma simultánea (ej. losartán + amlodipino). Aunque IECA y ARA2 Genen resultados comparables, muchos pacientes prefieren el losartán sobre el enalapril, debido a que se toma una vez al día.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: C**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

Tos seca por IECA (enalapril): efecto de clase por acumulación de bradicinina, ocurre en 10-15% de pacientes. Solución: cambiar a ARA II (Losartán, Valsartán) que no causan tos. El control hipertensivo se mantiene con igual eficacia sin el efecto adverso.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

Suspender amlodipino

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual**

Valsartán (ARA II)

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva**

Se trata de una Urgencia Hipertensiva (alza tensional severa sin daño de órgano blanco). El manejo correcto es el reposo inicial seguido de antihipertensivos orales y control ambulatorio en 24-48 horas. No requiere hospitalización en UCI ni nitroprusiato EV. El nifedipino sublingual está contraindicado.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

1.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva**

En la Disección Aórtica Aguda (emergencia hipertensiva hiperaguda), el objetivo vital es reducir drásticamente el estrés de cizallamiento sobre la pared aórtica (dP/dt). Se debe reducir de inmediato la PAS a < 120 mmHg y la FC a < 60 lpm en < 20 minutos usando Betabloqueadores endovenosos (Labetalol) como primera línea, asociando vasodilatadores si es necesario.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: D**

1.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco**

Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo (maquinaria) es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

1.01.1.021, 1.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco**

Las guías internacionales de la ESC y consensos clínicos establecen que el tratamiento estándar de primera línea de la pericarditis aguda es la asociación de AINEs (Ibuprofeno o Aspirina en dosis altas) con Colchicina durante 3 meses, debido a que la adición de colchicina disminuye a la mitad la tasa de recurrencias y recidivas.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

1.01.1.021, 1.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco**

La paciente presenta un Taponamiento Cardíaco Neoplásico clásico (Tríada de Beck completa: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados, más Pulso Paradojal severo > 10 mmHg). El único tratamiento salvavidas de emergencia es la evacuación inmediata del líquido mediante Pericardiocentesis.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

1.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

**Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco**

Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A**

1.01.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal**

Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

1.01.1.023, 1.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal**

Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

1.01.1.023, 1.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal**

El umbral de diámetro para indicar la reparación quirúrgica profiláctica o endovascular (EVAR) de un aneurisma de aorta abdominal en hombres es de ≥ 5.5 cm (o ≥ 5.0 cm en mujeres), dado que sobre este tamaño el riesgo anual de rotura fatal supera los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

1.01.1.026, 1.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)**

En pacientes con probabilidad clínica ALTA de TEP (Wells > 4 o > 6 según escala), el Dímero D carece de utilidad diagnóstica porque un valor normal no permite descartar con seguridad la patología. Se debe proceder de inmediato a la prueba confirmatoria estándar de oro que es el AngioTAC de Arterias Pulmonares.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)**

1.01.1.026, 1.01.2.008

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

La presencia de hipotensión sostenida o shock en un paciente con TEP define a un TEP Masivo o de Alto Riesgo Vital por claudicación del ventrículo derecho. La indicación mandataria de emergencia es la reperfusión farmacológica mediante Fibrinólisis Sistémica con Alteplasa (rt-PA 100 mg EV) para lisar el trombo y desobstruir el lecho vascular pulmonar.

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 02 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# INFECTOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Microbiología Clínica

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Infectología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC** | | | | | |
| 1.04.2.001 | Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q11, Q12 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.002 | Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.003 | Endocarditis bateriana | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1, Q2, Q3 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.2.004 | Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.04.2.005 | Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16, Q17, Q18 | Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.04.2.006 | Meningitis Aguda Bacteriana y Viral | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 02 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.04.2.007 | Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 2: SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS** | | | | | |
| 1.04.1.007 | Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33, Q34, Q35 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.009 | Diarrea asociada a antibióticos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q20, Q21, Q22 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |
| 1.04.1.015 | IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31, Q32 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.1.026 | Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.029 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.2.009 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.2.011 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.3.001 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.002 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.3.005 | IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q31, Q32 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.3.008 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.3.009 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.010 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.012 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| **BLOQUE 3: INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS** | | | | | |
| 1.04.1.005 | Candidiasis oral y esofágica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |
| 1.04.1.010 | Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.1.014 | Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |
| 1.04.1.019 | Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q41, Q42, Q43 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| 1.04.1.023 | Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47, Q48, Q49 | Tomo 02 · 3.4 (Pág. 33) |
| 1.04.1.028 | Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q44, Q45, Q46 | Tomo 02 · 3.3 (Pág. 31) |
| 1.04.3.006 | Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| 1.04.3.009 | Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q45, Q46 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| **BLOQUE 4: ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES** | | | | | |
| 1.04.1.003 | Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50) |
| 1.04.1.004 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.008 | Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q61, Q62, Q63 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.012 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.013 | Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q65, Q66, Q67 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.017 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.018 | Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.022 | Parasitosis intestinales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79) |
| 1.04.1.027 | Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q66, Q67, Q68 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.2.008 | Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58 | Tomo 02 · 4.1 (Pág. 40) |
| 1.04.4.016 | Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q59, Q60 | Tomo 02 · 4.2 (Pág. 42) |
| **BLOQUE 5: INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO** | | | | | |
| 1.04.1.001 | Adenitis, adenoflegmón | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.04.1.006 | Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78 | Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55) |
| 1.04.1.011 | Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85, Q86 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.016 | Influenza | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |
| 1.04.1.020 | Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88, Q89 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.021 | Osteomielitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77) |
| 1.04.1.024 | Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89, Q90 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.025 | Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81 | Tomo 02 · 5.2 (Pág. 57) |
| 1.04.2.010 | Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86, Q87 | Tomo 02 · 5.4 (Pág. 61) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Infectología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.001 | Adenitis, adenoflegmón | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.04.1.003 | Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50) |
| 1.04.1.004 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.005 | Candidiasis oral y esofágica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |
| 1.04.1.006 | Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78 | Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55) |
| 1.04.1.007 | Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33, Q34, Q35 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.008 | Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q61, Q62, Q63 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.009 | Diarrea asociada a antibióticos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q20, Q21, Q22 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |
| 1.04.1.010 | Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.1.011 | Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85, Q86 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.012 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.013 | Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q65, Q66, Q67 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.1.014 | Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |
| 1.04.1.015 | IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31, Q32 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.1.016 | Influenza | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |
| 1.04.1.017 | Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.018 | Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.019 | Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q41, Q42, Q43 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| 1.04.1.020 | Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88, Q89 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.021 | Osteomielitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77) |
| 1.04.1.022 | Parasitosis intestinales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79) |
| 1.04.1.023 | Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47, Q48, Q49 | Tomo 02 · 3.4 (Pág. 33) |
| 1.04.1.024 | Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89, Q90 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.025 | Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81 | Tomo 02 · 5.2 (Pág. 57) |
| 1.04.1.026 | Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.027 | Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q66, Q67, Q68 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.1.028 | Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q44, Q45, Q46 | Tomo 02 · 3.3 (Pág. 31) |
| 1.04.1.029 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.2.001 | Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q11, Q12 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.002 | Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.003 | Endocarditis bateriana | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1, Q2, Q3 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.2.004 | Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.04.2.005 | Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16, Q17, Q18 | Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.04.2.006 | Meningitis Aguda Bacteriana y Viral | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 02 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.04.2.007 | Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5 | Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.04.2.008 | Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58 | Tomo 02 · 4.1 (Pág. 40) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.2.009 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.2.010 | Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86, Q87 | Tomo 02 · 5.4 (Pág. 61) |
| 1.04.2.011 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 02 · Infectología (Pág. 8) |
| 1.04.3.001 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.002 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.3.005 | IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q31, Q32 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.3.006 | Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| 1.04.3.008 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.3.009 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26, Q45, Q46 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.010 | Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16) |
| 1.04.3.012 | Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 2.2 (Pág. 18) |
| 1.04.4.016 | Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q59, Q60 | Tomo 02 · 4.2 (Pág. 42) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC

PREGUNTA 1 1.04.2.003

**1.** **Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T°: 38,2°C, PA: 120/80 mmHg, FC: 94x', se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores y, en el examen cardíaco, se aprecia un soplo diastólico de intensidad IV/VI. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que destaca PCR: 12 mg/L, VHS: 70 mm/h y leucocitosis de 16.000 por mm3. Además, se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas Gram positivas, en cadena. ¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Penicilina sódica
B) Cloxacilina
C) Clindamicina
D) Ceftazidima
E) Gentamicina

PREGUNTA 2 1.04.2.003

**2.** **Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?**

A) Staphylococcus aureus o S. epidermidis
B) Streptococcus viridans
C) Enterococcus faecalis
D) HACEK group
E) Candida albicans

PREGUNTA 3 1.04.2.003

**3.** **Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:**

A) Absceso cerebral
B) Tuberculosis meníngea
C) Meningitis bacteriana
D) Endocarditis bacteriana
E) Leucemia mieloide aguda

PREGUNTA 4 1.04.2.007

**4.** **Un paciente de 62 años con neumonía adquirida en la comunidad grave evoluciona con taquipnea (FR 28 rpm), compromiso de conciencia y PA 80/50 mmHg. A pesar de la administración de 2.000 mL de solución salina al 0.9% en 90 minutos, la PAM persiste en 58 mmHg y el lactato sérico se reporta en 3.6 mmol/L. ¿Cuál es la conducta farmacológica inmediata más indicada?**

A) Iniciar infusión continua de dopamina a dosis beta
B) Iniciar infusión de noradrenalina con meta de PAM ≥ 65 mmHg
C) Administrar un bolo de 100 mg de hidrocortisona EV antes de vasopresores
D) Continuar la carga de cristaloides con 2.000 mL adicionales en 1 hora
E) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio 2/3 molar

PREGUNTA 5 1.04.2.007

**5.** **¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de sepsis en el servicio de urgencia?**

A) Temperatura axilar > 38.3 °C o < 36.0 °C
B) Leucocitosis > 12.000/mm³ o baciliformes > 10%
C) Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto
D) Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto
E) Diuresis horaria < 0.5 mL/kg/h

PREGUNTA 6 1.04.2.006

**6.** **Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5°C, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. El diagnóstico más probable es:**

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis meningococica
C) Meningitis neumocócica
D) Meningitis por listeria
E) Meningitis herpética

PREGUNTA 7 1.04.2.006

**7. Hombre de 58 años es traído a urgencias con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca y sopor. Al examen se constata hemiparesia braquiocrural derecha leve y signo de Babinski ipsilateral. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?**

A) Realizar punción lumbar de urgencia de inmediato y esperar el Gram para iniciar fármacos
B) Tomar hemocultivos, administrar dexametasona y antibióticos EV de inmediato, y luego solicitar TAC cerebral
C) Trasladar a TAC cerebral de inmediato sin administrar fármacos para no interferir con los cultivos
D) Iniciar infusión de manitol al 15% y diferir todo estudio invasivo por 24 horas
E) Administrar ceftriaxona en dosis única intramuscular y enviar a domicilio con control en 12 horas

PREGUNTA 8 1.04.2.006

**8. Se recibe el informe del citoquímico de LCR de un joven de 21 años previamente sano con fiebre y rigidez de nuca: aspecto transparente, leucocitos 180/mm³ con 88% de mononucleares, glucosa en LCR 62 mg/dL (glicemia sérica simultánea 98 mg/dL) y proteínas 68 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae
B) Meningitis bacteriana por Listeria monocytogenes
C) Meningitis viral (aséptica)
D) Meningitis tuberculosa en fase avanzada
E) Meningitis fúngica por Cryptococcus neoformans

PREGUNTA 9 1.04.2.006

**9. Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalo- rraquídeo con 610 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Ceftriaxona endovenosa
B) Cloxacilina endovenosa
C) Vancomicina endovenosa
D) Imipenem endovenoso
E) Ciprofloxacino oral

PREGUNTA 10 1.04.2.001

**10. Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis presenta alucinaciones olfatorias y afasia de comprensión. La TAC cerebral inicial sin contraste no muestra lesiones evidentes. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato
B) Indicar tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina EV y observar
C) Esperar el resultado de la PCR viral en LCR antes de indicar antivirales
D) Iniciar Dexametasona oral y enviar a domicilio con reposo
E) Solicitar electroencefalograma ambulatorio para descartar pseudocrisis

PREGUNTA 11 1.04.2.001, 1.04.2.002

**11. Una mujer de 35 años consulta por fiebre de 38.5 °C, cefalea y desorientación de 48 horas. Durante la anamnesis presenta alucinaciones olfatorias y afasia de comprensión. La TAC cerebral inicial sin contraste no muestra lesiones evidentes. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Iniciar Aciclovir endovenoso de inmediato
B) Indicar tratamiento con Ceftriaxona y Vancomicina EV y observar
C) Esperar el resultado de la PCR viral en LCR antes de indicar antivirales
D) Iniciar Dexametasona oral y enviar a domicilio con reposo
E) Solicitar electroencefalograma ambulatorio para descartar pseudocrisis

PREGUNTA 12 1.04.2.001, 1.04.2.002

**12. ¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos empíricos es el de elección para el tratamiento de un absceso cerebral secundario a una otitis media crónica no complicada con neurocirugía previa?**

A) Ceftriaxona + Metronidazol EV
B) Ciprofloxacino + Clindamicina oral
C) Vancomicina + Gentamicina EV
D) Ampicilina en monoterapia EV
E) Cefazolina + Dexametasona EV

PREGUNTA 13 1.04.2.002

**13. Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm3, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. El diagnóstico más probable es:**

A) Meningitis bacteriana aguda
B) Meningitis tuberculosa
C) Meningoencefalitis herpética
D) Meningitis por enterovirus
E) Meningitis por VIH

PREGUNTA 14 1.04.2.004

**14. Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho con marcado edema y dolor intenso. A la palpación se detecta crepitación subcutánea y se aprecian flictenas hemorrágicas en el centro de la lesión. El paciente se encuentra febril (39 °C) e hipotenso (PA 80/50 mmHg). ¿Cuál es la conducta prioritaria en este momento?**

A) Solicitar resonancia magnética nuclear urgente del muslo para evaluar la profundidad del compromiso
B) Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso
C) Iniciar Cloxacilina 2 g EV y reevaluar los límites del eritema en 12 horas
D) Realizar punción aspirativa con aguja fina en la zona crepitante para cultivo y esperar resultado
E) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir el edema de partes blandas

PREGUNTA 15 1.04.2.004, 1.04.2.005

**15. Un paciente diabético de 52 años es evaluado en el box de reanimación por una lesión eritematosa en el muslo derecho con marcado edema y dolor intenso. A la palpación se detecta crepitación subcutánea y se aprecian flictenas hemorrágicas en el centro de la lesión. El paciente se encuentra febril (39 °C) e hipotenso (PA 80/50 mmHg). ¿Cuál es la conducta prioritaria en este momento?**

A) Solicitar resonancia magnética nuclear urgente del muslo para evaluar la profundidad del compromiso
B) Trasladar de inmediato a pabellón para exploración y desbridamiento quirúrgico extenso
C) Iniciar Cloxacilina 2 g EV y reevaluar los límites del eritema en 12 horas
D) Realizar punción aspirativa con aguja fina en la zona crepitante para cultivo y esperar resultado
E) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir el edema de partes blandas

PREGUNTA 16 1.04.2.004, 1.04.2.005

**16. Un paciente de 38 años consulta por aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular de 48 horas de evolución, posterior a la extracción del tercer molar inferior izquierdo. Al examen se observa cuello en embudo, elevación de la lengua contra el paladar duro, trismus moderado, voz engolada y estridor inspiratorio intermitente. ¿Cuál es la prioridad médica inmediata?**

A) Asegurar la vía aérea de forma inmediata mediante intubación guiada o traqueostomía
B) Solicitar TAC de cuello con contraste para drenaje percutáneo
C) Administrar antibióticos orales con Amoxicilina/Clavulánico y analgesia
D) Realizar laringoscopía indirecta con espejo en el box dental
E) Indicar nebulizaciones con adrenalina racémica y hospitalizar en sala básica

PREGUNTA 17 1.04.2.005

**17. Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:**

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Pioderma gangrenoso
D) Fasceítis necrotizante
E) Celulitis bacteriana

PREGUNTA 18 1.04.2.005

**18. Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:**

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Ántrax
D) Fasceítis necrotizante
E) Miositis necrotizante

## BLOQUE 2 SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS

PREGUNTA 19 1.04.1.009

**19. Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al axamen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. ¿Cuál es el agente etiológico?**

A) Escherichia coli
B) Clostridium difficile
C) Shiguella flexneri
D) Rotavirus
E) Campilobacter jejuni

PREGUNTA 20 1.04.1.009

**20. Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Hidratación por vía oral abundante
B) Metronidazol oral
C) Ciprofloxacino oral
D) Clindamicina ev
E) Probióticos orales

PREGUNTA 21 1.04.1.009

**21. Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:**

A) Diarrea debida a Clostridium difficile
B) Colitis ulcerativa
C) Enfermedad de Cröhn
D) Colitis inespecífica
E) Shigellosis

PREGUNTA 22 1.04.1.009

**22. Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado: a. Diarrea por clostridium (sg yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB) b. Reagudización de diverticulitis por rectitis c. Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU**

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

PREGUNTA 23 1.04.1.029

**23. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19 · 1.04.1.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 24 1.04.2.011

**24. [URGENCIA: Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19 · 1.04.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 25 1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010

**25. Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir?**

A) Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir
B) Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas
C) Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa
D) Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato y esperar resultado
E) Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

PREGUNTA 26 1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010

**26. Niño de 8 años, contacto intradomiciliario de padre con tuberculosis bacilífera. Baciloscopía negativa, radiografía normal, PPD 6 mm. ¿Cuál es la conducta?**

A) Iniciar tratamiento antituberculoso completo con 4 fármacos
B) No requiere profilaxis ya que el PPD es negativo (< 10 mm)
C) Isoniazida por 3 meses y controlar con nuevo PPD al término
D) Isoniazida por 6 meses sin necesidad de control posterior
E) Vacunar con BCG y observar evolución

PREGUNTA 27 1.04.2.009

**27. Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. ¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?**

A) Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
B) Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
C) Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
D) Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
E) Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

PREGUNTA 28 1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

**28. Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. ¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?**

A) Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea
B) Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato
C) Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días
D) Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias
E) Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

PREGUNTA 29 1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

**29. Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra el tétanos está al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo hace 3 años. ¿Cuál es la indicación correcta?**

A) Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina
B) Administrar refuerzo con toxoide tetánico (dT)
C) Administrar inmunoglobulina antitetánica (IGH-T) en dosis de 250 UI
D) Administrar vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica
E) Iniciar profilaxis antibiótica con ciprofloxacino por 10 días

PREGUNTA 30 1.04.1.015

**30. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?**

A) Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
B) Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
C) Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
D) Coqueluche por Bordetella pertussis
E) Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

PREGUNTA 31 1.04.1.015, 1.04.3.005

**31. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95?**

A) Meningitis aguda por Neisseria meningitidis
B) Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva
C) Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile
D) Coqueluche por Bordetella pertussis
E) Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

PREGUNTA 32 1.04.1.015, 1.04.3.005

**32. Un paciente de 58 años en hemodiálisis por fístula nativa en maduración es portador de un catéter tunelizado yugoslavo. Consulta por fiebre de 38.8 °C post-diálisis. Los hemocultivos periféricos y del catéter resultan positivos para Candida albicans. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al catéter?**

A) Mantener el catéter e iniciar fluconazol endovenoso con técnica de sellado de catéter
B) Retirar inmediatamente el catéter y administrar terapia antifúngica sistémica
C) Recambiar el catéter sobre una guía de alambre en el mismo sitio
D) Observar por 48 horas tras iniciar antifúngicos y retirar solo si persiste la fiebre
E) Instilar etanol al 70% por los lúmenes y mantener el catéter para diálisis

PREGUNTA 33 1.04.1.007

**33. Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito recalentado en un almuerzo de oficina. No presentan fiebre ni deposiciones diarreicas. ¿Cuál es el patógeno causal más probable?**

A) Salmonella enteritidis
B) Bacillus cereus (forma emética)
C) Clostridium perfringens
D) Escherichia coli enterotoxigénica
E) Campylobacter jejuni

PREGUNTA 34 1.04.1.007, 1.04.1.026

**34. Un grupo de colegas de trabajo presenta náuseas y vómitos severos unas 3 horas después de compartir arroz frito recalentado en un almuerzo de oficina. No presentan fiebre ni deposiciones diarreicas. ¿Cuál es el patógeno causal más probable?**

A) Salmonella enteritidis
B) Bacillus cereus (forma emética)
C) Clostridium perfringens
D) Escherichia coli enterotoxigénica
E) Campylobacter jejuni

PREGUNTA 35 1.04.1.007, 1.04.1.026

**35. Una mujer de 52 años es llevada a urgencias por presentar visión doble (diplopía), caída de los párpados y dificultad para tragar de inicio progresivo hace 24 horas, agregándose debilidad en extremidades superiores. Refiere haber consumido conservas caseras de espárragos el día anterior. Al examen físico se constata ptosis palpebral bilateral, midriasis arreactiva y tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendíneos disminuidos. La sensibilidad es normal y está afebril. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A) Iniciar infusión de plasmaféresis por sospecha de Síndrome de Guillain-Barré
B) Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica
C) Administrar Ceftriaxona 2 g EV por sospecha de meningitis bacteriana
D) Indicar tratamiento con Piridostigmina oral por probable crisis miasténica
E) Administrar bolo de metilprednisolona EV por sospecha de esclerosis múltiple

PREGUNTA 36 1.04.1.026

**36. Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?: a. Azitromicina**

B) Hidratacion + probioticos
C) Ciprofloxacino
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

## BLOQUE 3 INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS

PREGUNTA 37 1.04.1.005

**37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Candidiasis oral y esofágica · 1.04.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Candidiasis oral y esofágica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.04.1.014

**38. Un paciente de 37 años consulta por fiebre y malestar general de dos días de evolución, asociado a odinofagia. Al examen físico, tiene FC: 96x', PA: 110/70 mmHg, T°: 38,0°C. Se observan úlceras orales, se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa un exantema maculopapular eritematoso con distribución predominante en el tronco. Su examen cardiopulmonar es normal. Al examen neurológico, presenta algún grado de confusión y se palpa rigidez de nuca esbozada. Presenta serología negativa para VIH y para virus de Epstein Barr y se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear y glucorraquia de 55 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Primoinfección por VIH
B) Meningoencefalitis por citomegalovirus
C) Meningitis bacteriana aguda
D) Neurosífilis
E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 39 1.04.1.014

**39. Un joven de 24 años se realiza un test rápido visual para VIH en una campaña universitaria, el cual resulta reactivo. ¿Cuál es la conducta médica normativa que se debe seguir en el sistema de salud chileno?**

A) Informar al paciente que tiene infección por VIH confirmada e iniciar de inmediato el tratamiento con antirretrovirales
B) Tomar una segunda muestra de sangre venosa y derivarla al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmación
C) Solicitar carga viral para VIH y dar por confirmado el diagnóstico si esta supera las 1.000 copias/mL
D) Repetir el test rápido visual en 3 meses para descartar el período de ventana
E) Derivar a infectología con diagnóstico de SIDA etapa C3

PREGUNTA 40 1.04.1.014

**40. ¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de infección por VIH en Chile según la guía ministerial vigente?**

A) Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
B) Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir
C) Abacavir + Emtricitabina + Lopinavir/Ritonavir
D) Efavirenz + Zidovudina + Atazanavir
E) Tenofovir alafenamida en monoterapia

PREGUNTA 41 1.04.1.019

**41. Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Stafilococcus aureus
B) Candida albicans
C) Streptococcus pyogenes
D) Mucor
E) Pseudomona aureginosa

PREGUNTA 42 1.04.1.019, 1.04.3.006

**42. Un paciente de 38 años con VIH y recuento de CD4 de 85 células/mm³ es diagnosticado de neumonía por Pneumocystis jirovecii. Los gases arteriales respirando aire ambiental muestran una PaO2 de 58 mmHg. Además del tratamiento antimicrobiano con Cotrimoxazol a dosis altas, ¿cuál de las siguientes medidas farmacológicas reduce la mortalidad?**

A) Iniciar infusión de N-acetilcisteína como antioxidante alveolar
B) Administrar corticoides sistémicos (Prednisona) antes o junto con el antibiótico
C) Indicar tratamiento concomitante con Azitromicina para cobertura de bacterias atípicas
D) Asociar Ganciclovir por probable coinfección con Citomegalovirus
E) Iniciar diuréticos de asa para reducir el edema alveolar

PREGUNTA 43 1.04.1.019, 1.04.3.006

**43. Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5 días de evolución. Su recuento de CD4 es de 45 células/mm³. La RMN cerebral con contraste muestra tres lesiones nodulares con captación en anillo y edema circundante localizadas en el tálamo y ganglios basales izquierdos. ¿Cuál es la conducta médica inicial más adecuada?**

A) Indicar biopsia estereotáxica urgente de la lesión talámica
B) Iniciar radioterapia holocraneana por sospecha de linfoma primario del SNC
C) Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días
D) Administrar anfotericina B liposomal en monoterapia EV
E) Indicar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos por 12 meses

PREGUNTA 44 1.04.1.028

**44. Un paciente de 54 años, con antecedente de artri8s reumatoide severa, inicia tratamiento con cor8coides sistémicos y terapia biológica, por lo que se realiza estudio de tuberculosis latente con PPD, el que resulta posi8vo, indicándose tratamiento con isoniacida por 6 meses, permaneciendo asintomá8co. Un año después consulta por lumbago muy intenso, EVA 8/10, de 10 días de evolución, que ha empeorado en los úl8mos días y no ha respondido a analgésicos. En el examen Fsico el dolor limita los movimientos de flexoextensión. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 30% con hemoglobina: 10 g/dL, glóbulos blancos: 12.000/mm³, plaquetas: 480.000/mm³ y VHS: 80 mm/h. La radiograFa de tórax es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente?**

A) Radiogra:a de columna lumbar
B) Resonancia magné2ca nuclear lumbar
C) Cin2gra:a ósea
D) ELISPOT
E) PET-scan

PREGUNTA 45 1.04.1.028, 1.04.3.009

**45. Un paciente de 35 años consulta por dolor torácico pleurítico y disnea. La toracocentesis diagnóstica obtiene un líquido pleural de aspecto cetrino con recuento de 2.400 leucocitos/mm³, 88% mononucleares, glucosa 48 mg/dL, proteínas 4.8 g/dL y nivel de Adenosina Deaminasa (ADA) de 54 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Empiema paraneumónico complicado por Streptococcus pneumoniae
B) Pleuritis tuberculosa
C) Derrame pleural por insuficiencia cardíaca descompensada
D) Mesotelioma pleural maligno
E) Lupus eritematoso sistémico con serositis

PREGUNTA 46 1.04.1.028, 1.04.3.009

**46. Un paciente de 28 años que inició tratamiento antituberculoso hace 3 semanas consulta alarmado porque su orina y saliva se han tornado de color anaranjado intenso. No refiere molestias urinarias, fiebre ni prurito. Las pruebas hepáticas son normales. ¿Cuál es la conducta médica indicada?**

A) Suspender de inmediato todo el esquema antituberculoso por sospecha de falla hepática
B) Tranquilizar al paciente, explicar que es un efecto farmacológico benigno de la rifampicina y continuar el esquema
C) Reemplazar la rifampicina por levofloxacino
D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo por sospecha de hematuria macroscópica
E) Reducir la dosis de isoniazida a la mitad

PREGUNTA 47 1.04.1.023

**47. Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pitiriasis rosada
B) Pitiriasis versicolor
C) Síndrome pie mano boca
D) Sífilis secundaria
E) Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

PREGUNTA 48 1.04.1.023

**48. Un hombre de 24 años consulta por un exantema eritematoso difuso en tronco que compromete francamente las palmas de las manos y las plantas de los pies, sin prurito, de 1 semana de evolución. Hace 2 meses recuerda haber tenido una úlcera indolora en el pene que desapareció espontáneamente. El VDRL es reactivo 1:64. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única
B) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas consecutivas
C) Ceftriaxona 1 g EV diario por 14 días
D) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 7 días
E) Azitromicina 1 g oral en dosis única

PREGUNTA 49 1.04.1.023

**49.** **Una mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta un VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado mediante FTA-ABS reactivo. La paciente refiere ser alérgica confirmada a la penicilina (presentó shock anafiláctico previo). ¿Cuál es la conducta médica indicada para prevenir la sífilis congénita?**

A) Indicar tratamiento con Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días
B) Hospitalizar para desensibilización oral a la penicilina y luego administrar Penicilina Benzatina
C) Administrar Eritromicina oral 500 mg cada 6 horas por 14 días
D) Diferir todo tratamiento antibiótico hasta después del parto para evitar teratogenia
E) Administrar Ceftriaxona 1 g diario intramuscular por 10 días

PREGUNTA 50 1.04.1.010

**50.** **Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Mycoplasma genitalium
B) Ureaplasma urealyticum
C) Chlamydia trachomatis
D) Trichomona vaginalis
E) Escherichia coli

PREGUNTA 51 1.04.1.010

**51.** **Un hombre de 25 años consulta por disuria y secreción uretral purulenta abundante. La tinción de Gram de la secreción demuestra diplococos Gram negativos intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única en monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + Doxiciclina 100 mg cada 12 h oral por 7 días
C) Ciprofloxacino 500 mg oral en dosis única
D) Azitromicina 500 mg diarios por 3 días
E) Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

PREGUNTA 52 1.04.1.010

**52.** **Una mujer de 22 años consulta por intenso dolor vulvar y ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen ginecológico se aprecian múltiples vesículas agrupadas y pequeñas úlceras superficiales eritematosas muy sensibles en ambos labios mayores, con adenopatías inguinales dolorosas bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento indicado?**

A) Chancroide / Ceftriaxona IM
B) Sífilis primaria / Penicilina Benzatina IM
C) Herpes genital primario / Aciclovir oral
D) Linfogranuloma venéreo / Doxiciclina oral
E) Candidiasis vulvovaginal / Fluconazol oral

PREGUNTA 53 1.04.1.010

**53.** **Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:**

A) Neisseria gonorrhoeae
B) Treponema pallidum
C) Chlamydia trachomatis
D) Mycoplasma genitalium
E) Streptococcus pyogenes

PREGUNTA 54 1.04.1.010

**54.** **Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Trichomona vaginalis
B) Treponema pallidum
C) Ureaplasma urealyticum
D) Mycoplasma genitalis
E) Chlamydia trachomatis

## BLOQUE 4 ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES

PREGUNTA 55 1.04.1.022

**55.** **IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:**

A) Mebendazol
B) Albendazol
C) Praziquantel
D) Ivermectina
E) Derrame pleural

PREGUNTA 56 1.04.2.008

**56.** **Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en zona rural del sur de Chile. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia. ¿Cuál es el agente causal más probable?**

A) Hantavirus (Sin Nombre)
B) Leptospira interrogans
C) Rickettsia conorii
D) Yersinia pestis
E) Francisella tularensis

PREGUNTA 57 1.04.2.008

**57.** **Un trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por cuadro de 3 días de fiebre alta, dolor muscular severo en muslos y sensación de falta de aire. El hemograma muestra Hematocrito de 52%, leucocitos de 16.000/mm³ con 12% de inmunoblastos y recuento de plaquetas de 48.000/mm³. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas está formalmente contraindicada o debe evitarse?**

A) Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo
B) Oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación
C) Monitoreo estricto de diuresis horaria
D) Traslado en ambulancia avanzada con médico
E) Toma de serología para IgM específica

PREGUNTA 58 1.04.2.008

**58.** **¿Cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente del virus Hanta en Chile según la epidemiología nacional?**

A) Picadura del mosquito Aedes aegypti
B) Inhalación de aerosoles contaminados con excretas de ratón colilargo
C) Consumo de carne cruda de cerdo
D) Mordedura directa de murciélago silvestre
E) Contacto sexual con personas asintomáticas

PREGUNTA 59 1.04.4.016

**59.** **¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la transmisión congénita de la Enfermedad de Chagas en un recién nacido hijo de madre seropositiva durante sus primeros días de vida?**

A) Serología ELISA IgG en sangre del recién nacido
B) Examen parasitológico directo mediante microhematocrito en sangre fresca
C) Western Blot específico para anticuerpos IgM anti-Trypanosoma cruzi
D) Radiografía de tórax y ecocardiograma neonatal
E) Esperar a los 15 años de vida para realizar tamizaje serológico

PREGUNTA 60 1.04.4.016

**60.** **Un hombre de 60 años originario de la Región de Coquimbo consulta por constipación crónica pertinaz de años de evolución que se ha agravado en los últimos meses, requiriendo enemas evacuantes periódicos. El enema baritado muestra marcada dilatación del colon sigmoides y recto. El electrocardiograma revela bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de colon izquierdo estenosante
B) Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada
C) Enfermedad de Hirschsprung del adulto
D) Colitis ulcerosa de larga data
E) Síndrome de colon irritable variante constipación

PREGUNTA 61 1.04.1.008

**61.** **Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días de un viaje por el Amazonas. El médico sospecha clínicamente infección por virus dengue. ¿Cuál de los siguientes fármacos analgésicos está formalmente contraindicado administrar a este paciente?**

A) Paracetamol
B) Ketoprofeno
C) Dipirona
D) Tramadol
E) Codeína

PREGUNTA 62 1.04.1.008, 1.04.1.018

**62.** **Un hombre de 30 años consulta en urgencias por fiebre de 39 °C, cefalea y artralgias intensas tras regresar hace 4 días de un viaje por el Amazonas. El médico sospecha clínicamente infección por virus dengue. ¿Cuál de los siguientes fármacos analgésicos está formalmente contraindicado administrar a este paciente?**

A) Paracetamol
B) Ketoprofeno
C) Dipirona
D) Tramadol
E) Codeína

PREGUNTA 63 1.04.1.008, 1.04.1.018

**63.** **Una mujer de 29 años presenta accesos febriles con calofríos intensos y sudoración profusa cada 48 horas tras regresar de un viaje por el sudeste asiático. La gota gruesa confirma la presencia de trofozoítos de Plasmodium vivax. Tras el tratamiento inicial con Cloroquina y desaparición de los parásitos en sangre, ¿cuál es la conducta necesaria para prevenir recaídas tardías?**

A) Administrar Primaquina oral durante 14 días
B) Continuar Cloroquina en dosis profiláctica por 6 meses
C) Indicar tratamiento con Doxiciclina por 21 días
D) Administrar vacuna antimalárica de refuerzo
E) No requiere fármacos adicionales dado que la cloroquina es curativa

PREGUNTA 64 1.04.1.018

**64.** **Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm3, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm3 y VHS: 35 mmHg. El agente etiológico más probable es:**

A) Viruz zika
B) Virus dengue
C) Plasmodium falciparum
D) Salmonella typhi
E) Virus de fiebre amarilla

PREGUNTA 65 1.04.1.013

**65.** **Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocrondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) IgG para Toxoplasma gondii
B) Serología para hidatidosis
C) Serología para Triquinella spiralis
D) IgG para Fasciola hepática (Distoma)
E) Examen parasitológico seriado de deposiciones

PREGUNTA 66 1.04.1.013, 1.04.1.027

**66.** **Un paciente de 35 años consulta por fiebre de 38.8 °C, dolor muscular difuso y marcado edema bipalpebral bilateral tras asistir hace dos semanas a una faena clandestina de cerdos donde consumió embutidos artesanales. El hemograma muestra leucocitosis con 38% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Triquinosis
B) Hidatidosis hepática complicada
C) Fiebre tifoidea
D) Dengue con signos de alarma
E) Enfermedad de Chagas aguda

PREGUNTA 67 1.04.1.013, 1.04.1.027

**67.** **Durante la realización de una ecografía abdominal de rutina a un campesino de 50 años asintomático, se identifica en el lóbulo hepático derecho una masa quística redondeada de 7 cm de diámetro con tabiques internos y desprendimiento de la membrana germinativa (signo del camalote). ¿Cuál es la complicación aguda más grave que puede presentar este paciente?**

A) Rotura espontánea o traumática con shock anafiláctico grave
B) Transformación a colangiocarcinoma metastásico en menos de 1 año
C) Desarrollo de hipertensión portal con cirrosis hepática descompensada
D) Perforación gástrica con hemorragia digestiva alta masiva
E) Fístula aortoentérica exanguinante

PREGUNTA 68 1.04.1.027

**68.** **Un paciente de 25 años que vive en una zona rural consulta por cefalea y mialgias intensas de 7 días de evolución, asociadas a malestar general y sensación febril. Al examen Fsico presenta temperatura: 37,5 °C, frecuencia cardíaca: 115 por minuto y presión arterial: 100/60 mmHg. Se solicitan exámenes que muestran PCR 5,6 mg/L (valor normal: menor a 0,5 mg/dl), hemograma con 15.000 glóbulos blancos/mm³, 290.000 plaquetas/mm³ y hematocrito de 35%. En la fórmula diferencial de la serie blanca presenta 40% de eosinófilos. Se solicitan CK, que resultan 2.500 U/L (VN: 30-170 U/L). El estudio ecocardiográfico es compa8ble con miocardi8s aguda. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Fasciolasis hepá2ca
B) Neurosis2cercosis
C) Hida2dosis
D) Infección por Trichinella spiralis
E) Infección por virus Coxsackie

PREGUNTA 69 1.04.1.004

**69.** **Veterinario expuesto a ganado, dolor articular. Artrocentesis con PMN 70% a. brucelosis b. Fiebre Q**

C) Cultivo de gonococo
D) Hemocultivo
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

PREGUNTA 70 1.04.1.012

**70.** **Un niño de 7 años presenta fiebre persistente desde hace 7 días, mayor en la tarde, hasta 38,9 °C, asociada a cefalea, anorexia y dolor abdominal. Al examen Fsico 8ene temperatura: 38,2 °C, frecuencia cardíaca: 62x' y frecuencia respiratoria: 15x'. Se palpa abdomen sensible de manera difusa, sin signos peritoneales. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 35%, glóbulos blancos: 3.700/mm³ con 70% segmentados, 9% cayados, 16% linfocitos, 5% monocitos, 0% eosinófilos y VHS 65 mm/h. Su proteína C reac8va resulta 6,9 mg/L (valor normal: < 0,5 mg/L). ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?**

A) Brucella melitensis
B) Salmonella typhi
C) Escherichia coli enterotoxigénica
D) Virus de Epstein-Barr
E) Citomegalovirus

PREGUNTA 71 1.04.1.017

**71.** **Un trabajador agrícola de 38 años consulta por fiebre de 39 °C, cefalea intensa y marcado dolor en las pantorrillas de 5 días de evolución, posterior a realizar labores de limpieza en un canal de regadío con aguas estancadas. Al examen se observa ictericia en escleras y marcada inyección conjuntival bilateral sin secreción purulenta (sufusión conjuntival). El laboratorio muestra Bilirrubina total 8.5 mg/dL de predominio directo, Creatinina 3.2 mg/dL y gases con acidosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leptospirosis ictérica (Síndrome de Weil)
B) Hepatitis viral aguda tipo A
C) Colangitis aguda supurada
D) Fiebre tifoidea complicada
E) Malaria por Plasmodium vivax

PREGUNTA 72 1.04.1.003

**72.** **Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda de 4 días de evolución. Al examen se observa una escara negruzca central de consistencia dura, rodeada por vesículas con líquido claro y un marcado edema indurado en toda la mano, sin dolor a la palpación ni secreción purulenta. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A) Ciprofloxacino oral
B) Cefazolina endovenosa
C) Flucloxacilina oral
D) Aciclovir tópico
E) Corticoides sistémicos a dosis altas

## BLOQUE 5 INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO

PREGUNTA 73 1.04.1.001

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Adenitis, adenoflegmón · 1.04.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Adenitis, adenoflegmón. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.04.1.016

**74.** **En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta 39 grados celsius, con examen pulmonar normal. El tratamiento más adecuado es:**

A) Oseltamivir
B) Zanamivir
C) Aciclovir
D) Valaciclovir
E) Paracetamol

PREGUNTA 75 1.04.1.021

**75.** **Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El antibiograma informa desarrollo de Staphylococcus aureus con el siguiente antibiograma: ¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?**

A) Flucloxacilina
B) Cefazolina
C) Vancomicina
D) Tetraciclina
E) Cotrimoxazol

PREGUNTA 76 1.04.1.006

**76.** **Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
B) Curaciones con povidona yodada
C) Mupirocina tópica
D) Amoxicilina oral por 7 días
E) Cefadroxilo oral por 7 días

PREGUNTA 77 1.04.1.006

**77.** **Una mujer de 64 años consulta por fiebre de 38.6 °C y dolor en la pierna izquierda. Al examen se observa una placa eritematosa caliente en la cara anteromedial de la pierna, con bordes sobreelevados, nítidos y bien delimitados respecto a la piel sana circundante. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable?**

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pyogenes
C) Staphylococcus epidermidis
D) Clostridium perfringens
E) Escherichia coli

PREGUNTA 78 1.04.1.006

**78.** **¿Cuál de los siguientes esquemas antimicrobianos por vía oral es el de primera línea para el tratamiento ambulatorio de una celulitis no complicada de extremidad inferior en un paciente adulto sin alergias?**

A) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas
B) Cefadroxilo 500 mg cada 12 horas
C) Metronidazol 500 mg cada 8 horas
D) Gentamicina oral 80 mg cada 8 horas
E) Doxiciclina 100 mg cada 24 horas

PREGUNTA 79 1.04.1.025

**79.** **Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen Fsico se observa paciente febril, con temperatura: 38,1 °C, frecuencia cardíaca: 100 por minuto y presión arterial: 118/78 mmHg; presenta faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño, se palpan adenopa`as cervicales anteriores bilaterales y, en el examen abdominal, se palpa el hígado 2 cm por debajo del reborde costal. Se solicitan exámenes, destacando: hemograma con hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/dL, VCM 88 fL, glóbulos blancos 15.600/mm³ con 70% linfocitos, 20% neutrófilos y 10% monocitos; pruebas hepá8cas con SGOT: 262 U/L, SGPT: 214 U/L, GGT: 90 U/L, fosfatasas alcalinas: 95 U/L y bilirrubina total: 1,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Infección por virus hepa22s A
B) Leucemia aguda
C) Toxoplasmosis aguda
D) Mononucleosis infecciosa
E) Amigdali2s bacteriana

PREGUNTA 80 1.04.1.025

**80.** **Un universitario de 20 años presenta fiebre de 39 °C, disfagia intensa y astenia de una semana. Se le diagnosticó faringitis estreptocócica hace 3 días y se le administró amoxicilina, presentando al segundo día un exantema eritematoso maculopapular generalizado. Al examen físico destaca faringe con placas pultáceas, adenopatías cervicales posteriores bilaterales y esplenomegalia palpable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Shock anafiláctico secundario a penicilina
B) Mononucleosis infecciosa por Virus Epstein-Barr
C) Escarlatina por Streptococcus pyogenes
D) Infección aguda por Citomegalovirus
E) Lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos

PREGUNTA 81 1.04.1.025

**81.** **Un recién nacido de 5 días de vida presenta microcefalia, ictericia y hepatoesplenomegalia. La ecografía transfontanelar revela calcificaciones periventriculares y el examen auditivo demuestra hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. ¿Cuál es el agente etiológico congénito más probable?**

A) Toxoplasma gondii
B) Citomegalovirus (CMV)
C) Treponema pallidum
D) Virus de la Rubéola
E) Virus Herpes Simplex tipo 2

PREGUNTA 82 1.04.1.011

**82.** **Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Clorfenamina oral
B) Aspirina oral
C) Aciclovir oral
D) Vacuna contra virus herpes 3
E) Inmunoglobulina G no específica

PREGUNTA 83 1.04.1.011

**83.** **Un niño de 5 años presenta dolor faríngeo y fiebre de 38.5 °C. Al examen destaca un exantema micropapular eritematoso difuso que palidece a la presión y tiene un tacto áspero similar a un papel de lija, con acentuación del eritema en los pliegues antecubitales formando líneas transversales que no palidecen (Líneas de Pastia). Se observa lengua con papilas hipertróficas rojas prominentes. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico indicado para este cuadro?**

A) Azitromicina 10 mg/kg/día por 3 días
B) Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días completos
C) Cefuroximo oral por 5 días
D) Ciprofloxacino oral por 7 días
E) No requiere antibióticos por tratarse de una infección viral autolimitada

PREGUNTA 84 1.04.1.011

**84.** **¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento precoz con Inmunoglobulina Endovenosa a altas dosis en un lactante diagnosticado con Enfermedad de Kawasaki?**

A) Prevenir la progresión a glomerulonefritis post-infecciosa
B) Evitar el desarrollo de aneurismas y ectasias en las arterias coronarias
C) Reducir la duración de la descamación periungueal
D) Erradicar la portación nasal de Streptococcus
E) Prevenir la reactivación por virus varicela zóster

PREGUNTA 85 1.04.1.011, 1.04.2.010

**85.** **Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución. Presenta desde hace 4 días un exantema vesicular polimórfico en cara y tronco compatible con varicela. La saturación de oxígeno es 89% con aire ambiental y la radiografía de tórax muestra infiltrados micronodulares bilaterales difusos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico prioritario?**

A) Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas
B) Aciclovir oral 800 mg cada 4 horas
C) Ceftriaxona más Claritromicina endovenosa
D) Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zóster intramuscular
E) Metilprednisolona endovenosa en pulsos

PREGUNTA 86 1.04.1.011, 1.04.2.010

**86. Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose hace 24 horas a la aparición de vesículas en racimo en la frente, el párpado superior y la punta de la nariz (signo de Hutchinson positivo). ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología
B) Indicar tratamiento con Carbamazepina y analgesia con Paracetamol
C) Aplicar ungüento tópico de corticoides en las lesiones nasales y párpado
D) Administrar vacuna de refuerzo contra herpes zóster
E) Realizar desbridamiento quirúrgico de las vesículas nasales

PREGUNTA 87 1.04.2.010

**87. Un hombre de 36 años fumador consulta por disnea aguda progresiva y tos con estrías de sangre de 24 horas de evolución. Presenta desde hace 4 días un exantema vesicular polimórfico en cara y tronco compatible con varicela. La saturación de oxígeno es 89% con aire ambiental y la radiografía de tórax muestra infiltrados micronodulares bilaterales difusos. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico prioritario?**

A) Aciclovir endovenoso a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas
B) Aciclovir oral 800 mg cada 4 horas
C) Ceftriaxona más Claritromicina endovenosa
D) Inmunoglobulina hiperinmune contra varicela zóster intramuscular
E) Metilprednisolona endovenosa en pulsos

PREGUNTA 88 1.04.1.020

**88. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

PREGUNTA 89 1.04.1.020, 1.04.1.024

**89. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

PREGUNTA 90 1.04.1.024

**90. Un paciente de 62 años que recibió quimioterapia intensiva hace 8 días por una leucemia mieloide aguda consulta en urgencias por fiebre de 38.7 °C y calofríos. Al examen no se identifica foco infeccioso evidente. El hemograma revela un recuento de leucocitos de 600/mm³ con 30% de neutrófilos totales (RAN 180/mm³). Tras la toma de hemocultivos, ¿cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Iniciar infusión endovenosa de Cefepime 2 g en menos de 60 minutos
B) Administrar Ceftriaxona 2 g EV más Vancomicina y hospitalizar en sala básica
C) Indicar tratamiento con Ciprofloxacino oral y control ambulatorio en 24 horas
D) Esperar el resultado de los hemocultivos para iniciar el antibiótico dirigido
E) Iniciar tratamiento antifúngico con Fluconazol oral en monoterapia

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 URGENCIAS CRÍTICAS, SEPSIS E INFECCIONES DEL SNC · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, que se trata con ampicilina o penicilina sódica.

### PREGUNTA 2 — Respuesta: A — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Endocarditis protésica precoz (<2 meses post-cirugía): causada por gérmenes hospitalarios, principalmente Staphylococcus aureus y S. epidermidis (estafilococos coagulasa negativos), adquiridos intraoperatoriamente.

### PREGUNTA 3 — Respuesta: D — Endocarditis bateriana

1.04.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

### PREGUNTA 4 — Respuesta: B

**Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente se encuentra en shock séptico refractario a fluidos (PAM < 65 mmHg y lactato > 2 mmol/L post-volumen). La recomendación Surviving Sepsis Campaign establece la Noradrenalina como el vasopresor de primera línea para restaurar la presión de perfusión tisular (PAM ≥ 65 mmHg). La dopamina (A) aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y mortalidad. Los corticoides (C) se indican solo en shock refractario a dosis altas de noradrenalina. Continuar aportando volumen a ciegas (D) provoca edema pulmonar y mayor falla ventricular.

### PREGUNTA 5 — Respuesta: C

**Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El qSOFA consta exclusivamente de tres parámetros clínicos de fácil evaluación sin requerir exámenes de laboratorio: (1) Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm, (2) Alteración del estado mental (Glasgow < 15), y (3) Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg. La temperatura, taquicardia y leucocitosis (A, B, D) pertenecían a los antiguos criterios de SIRS, los cuales fueron abandonados por su baja especificidad.

### PREGUNTA 6 — Respuesta: B

**Meningitis Aguda Bacteriana y Viral**

1.04.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un cuadro sugerente de MBA. Las petequias y equimosis son de meningococcemia.

### PREGUNTA 7 — Respuesta: B

**Meningitis Aguda Bacteriana y Viral**

1.04.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de focalidad neurológica (hemiparesia y Babinski) es una contraindicación formal para la punción lumbar inmediata por riesgo inminente de herniación cerebral fatal. Sin embargo, la regla médica absoluta es que NUNCA se debe postergar el inicio de los antibióticos por la realización de neuroimágenes. La conducta exacta es tomar hemocultivos inmediatos, administrar la Dexametasona EV + Ceftriaxona + Vancomicina + Ampicilina (por ser > 50 años), y proceder de inmediato a la realización del TAC.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

**Meningitis Aguda Bacteriana y Viral**

1.04.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El perfil de LCR muestra pleocitosis moderada a expensas de mononucleares/linfocitos, con proteínas levemente aumentadas y GLUCOSA NORMAL (ratio LCR/suero > 0.6). Este patrón es característico de meningitis viral (etiología enterovirus la más frecuente en adultos jóvenes). La bacteriana (A, B) y la tuberculosa/fúngica (D, E) cursan con hipoglucorraquia marcada (consumo patológico de glucosa).

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A** **Meningitis Aguda Bacteriana y Viral** 1.04.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una meningitis por meningococo, que se trata con ceftriaxona o penicilina endovenosas.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

**Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral**

1.04.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de fiebre asociada a síntomas del lóbulo temporal (alucinaciones olfatorias, afasia de comprensión, desorientación) configura una alta sospecha de encefalitis herpética. La TAC cerebral puede ser completamente normal en las primeras 48 a 72 horas. La conducta inmediata y que no admite demora es el inicio de Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h), el cual reduce la mortalidad de más de un 70% a menos del 20%.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: A**

**Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral**

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de fiebre asociada a síntomas del lóbulo temporal (alucinaciones olfatorias, afasia de comprensión, desorientación) configura una alta sospecha de encefalitis herpética. La TAC cerebral puede ser completamente normal en las primeras 48 a 72 horas. La conducta inmediata y que no admite demora es el inicio de Aciclovir EV (10 mg/kg c/8h), el cual reduce la mortalidad de más de un 70% a menos del 20%.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

**Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral**

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Los abscesos cerebrales contiguos secundarios a sinusitis u otitis media crónica son provocados típicamente por flora mixta polimicrobiana: estreptococos aerobios y anaerobios de la cavidad oral/orofaríngea (Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus). El esquema de elección es Ceftriaxona (cruza BHE con excelente cobertura para estreptococos) combinada con Metronidazol (excelente penetración en LCR y tejido necrótico contra anaerobios).

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: C**

**Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral**

1.04.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una meningoencefalitis herpética clásica, con la clínica de compromiso de conciencia (o convulsiones) y la clásica afectación de los lóbulos temporales. La punción sugiere infección viral (glucosa normal: sobre 40; y pleocitosis mononuclear), aunque le falta la presencia de glóbulos rojos, característica del herpes.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

**Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig**

1.04.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de flictenas hemorrágicas, crepitación y shock séptico en una infección de partes blandas es diagnóstica de fascitis necrotizante. La mortalidad se incrementa drásticamente por cada hora de demora quirúrgica. Ningún examen de imagen (A) ni procedimiento diagnóstico menor (D) debe retrasar el ingreso a pabellón. El tratamiento es quirúrgico inmediato (desbridamiento amplio de toda la fascia desvitalizada) asociado a reanimación y antibióticos EV de amplio espectro.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

1.04.2.004, 1.04.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig**

La presencia de flictenas hemorrágicas, crepitación y shock séptico en una infección de partes blandas es diagnóstica de fascitis necrotizante. La mortalidad se incrementa drásticamente por cada hora de demora quirúrgica. Ningún examen de imagen (A) ni procedimiento diagnóstico menor (D) debe retrasar el ingreso a pabellón. El tratamiento es quirúrgico inmediato (desbridamiento amplio de toda la fascia desvitalizada) asociado a reanimación y antibióticos EV de amplio espectro.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: A**

1.04.2.004, 1.04.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig**

El cuadro corresponde a una Angina de Ludwig con signos inminentes de compromiso obstructivo de la vía aérea (estridor inspiratorio, protrusión lingual, cuello en embudo). La causa número uno de muerte en esta patología es la asfixia por colapso de la hipofaringe. La prioridad médica absoluta antes de cualquier estudio radiológico o intervención quirúrgica del foco es el aseguramiento de la vía aérea mediante intubación con fibra óptica o traqueostomía de urgencia.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: D**

1.04.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig**

Si bien la parte iniciar del cuadro sugería una erisipela o celulitis (se diferencias fácilmente por los bordes nítidos o difusos, respectivamente), la presencia de zonas violáceas y bulas es sugerente de fasceítis necrotizante (la erisipela también puede tener pequeñas bulas). Lia...

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: D**

1.04.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig**

Es una fasceítis necrotizante clásica.

---

## BLOQUE 2 SALUD PÚBLICA, PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN E IAAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: B** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Diarrea post-ATB es por C. difficile en el 30% de los casos.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: B** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por C. difficile. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Diarrea asociada a antibióticos.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: A**

**Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes**

1.04.1.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19" (1.04.1.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: A**

**Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes**

1.04.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19" como urgencia clínica (1.04.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

**Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes**

1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Ante un accidente laboral de riesgo biológico con fuente desconocida o seropositiva, la profilaxis post-exposición (PEP) con triterapia debe ofrecerse e iniciarse de forma inmediata (idealmente < 2-4 horas, máximo 72 horas) por 28 días. No se debe postergar el inicio esperando el resultado serológico de la fuente (A), ya que la eficacia decae drásticamente tras las primeras horas.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: C**

**Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes**

1.04.3.001, 1.04.3.009, 1.04.3.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En menores de 15 años expuestos a un contacto bacilífero con PPD inicial negativo (< 10 mm en no infectados), la norma chilena indica quimioprofilaxis con Isoniazida de entrada durante 3 meses ("período de ventana inmunológica") y repetir el PPD: si al tercer mes continúa negativo se suspende; si positiviza (viraje), se completan 6 meses de tratamiento.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

**Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico**

1.04.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, el murciélago es el principal reservorio de rabia. Las mordeduras de murciélago pueden ser indoloras e imperceptibles. Según la norma MINSAL, el hallazgo de un murciélago en la misma habitación donde dormía una persona se considera una exposición de alto riesgo ("contacto no apercibido"). La indicación obligatoria es iniciar de inmediato la vacunación antirrábica completa (esquema de 5 dosis) junto con la administración de Inmunoglobulina antirrábica.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

**Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico**

1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, el murciélago es el principal reservorio de rabia. Las mordeduras de murciélago pueden ser indoloras e imperceptibles. Según la norma MINSAL, el hallazgo de un murciélago en la misma habitación donde dormía una persona se considera una exposición de alto riesgo ("contacto no apercibido"). La indicación obligatoria es iniciar de inmediato la vacunación antirrábica completa (esquema de 5 dosis) junto con la administración de Inmunoglobulina antirrábica.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: A**

1.04.2.009, 1.04.3.002, 1.04.3.008, 1.04.3.012

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

**Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico**

En un paciente con antecedente fidedigno de vacunación completa cuya última dosis fue administrada hace menos de 5 años, los títulos séricos de anticuerpos antitoxina son óptimos y protectores, incluso ante heridas sucias o tetanígenas. Por ende, solo se requiere aseo prolijo de la herida, sin indicación de toxoide ni de inmunoglobulina.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

1.04.1.015

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento**

La Tuberculosis pulmonar bacilífera activa se transmite mediante aerosoles con núcleos de gotitas microscópicas (< 5 micrones) que permanecen suspendidas en el aire por horas. Requiere aislamiento aéreo estricto con mascarilla de alta filtración (N95) y presión negativa en la habitación para evitar que los aerosoles pasen a los pasillos del hospital. El meningococo y coqueluche (A, D) usan aislamiento por gotitas (mascarilla quirúrgica simple); Clostridioides y bacterias BLEE (C, E) usan aislamiento de contacto.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

1.04.1.015, 1.04.3.005

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento**

La Tuberculosis pulmonar bacilífera activa se transmite mediante aerosoles con núcleos de gotitas microscópicas (< 5 micrones) que permanecen suspendidas en el aire por horas. Requiere aislamiento aéreo estricto con mascarilla de alta filtración (N95) y presión negativa en la habitación para evitar que los aerosoles pasen a los pasillos del hospital. El meningococo y coqueluche (A, D) usan aislamiento por gotitas (mascarilla quirúrgica simple); Clostridioides y bacterias BLEE (C, E) usan aislamiento de contacto.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

1.04.1.015, 1.04.3.005

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento**

La candidemia asociada a catéter venoso central es una infección invasiva de máxima gravedad con formación masiva de biofilm fúngico intra y extraluminal. La guía internacional y las normas de IAAS establecen que el catéter DEBE RETIRARSE INMEDIATAMENTE en toda infección por Candida spp., asociado a terapia antifúngica sistémica (Equinocandina o Fluconazol) y fondo de ojo para descartar endoftalmitis candidiásica.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

1.04.1.007

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera**

Bacillus cereus presenta dos formas clínicas bien diferenciadas: la forma emética (provocada por la toxina termoestable cereulida, con incubación muy corta de 1 a 5 horas y vómitos intensos, clásicamente asociada al arroz frito o recalentado) y la forma diarreica (incubación de 8 a 16 horas, mediada por enterotoxinas lábiles). Salmonella y Campylobacter (A, E) tienen períodos de incubación mayores a 16-24 horas y cursan con fiebre.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

1.04.1.007, 1.04.1.026

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera**

Bacillus cereus presenta dos formas clínicas bien diferenciadas: la forma emética (provocada por la toxina termoestable cereulida, con incubación muy corta de 1 a 5 horas y vómitos intensos, clásicamente asociada al arroz frito o recalentado) y la forma diarreica (incubación de 8 a 16 horas, mediada por enterotoxinas lábiles). Salmonella y Campylobacter (A, E) tienen períodos de incubación mayores a 16-24 horas y cursan con fiebre.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

1.04.1.007, 1.04.1.026

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

**Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera**

El antecedente de ingesta de conservas caseras sumado a la clínica de compromiso de pares craneanos (diplopía, ptosis, midriasis) y parálisis flácida descendente sin alteración sensitiva es patognomónico de Botulismo alimentario. El Guillain-Barré (A) es una parálisis típicamente ASCENDENTE (de piernas hacia arriba) y la miastenia (D) no causa midriasis ni disautonomía. La conducta urgente es ingreso a UCI por riesgo de fallo ventilatorio y administración de Antitoxina Botulínica equina inmediata.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

**Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera**

1.04.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 45). Evalúa el manejo clínico de Toxicoinfección alimentaria según directrices MINSAL vigentes.

## BLOQUE 3 INFECCIONES CRÓNICAS, RETROVIRALES Y GRANULOMATOSAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Candidiasis oral y esofágica** 1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Candidiasis oral y esofágica" (1.04.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A**

**Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)**

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome retroviral agudo o primoinfección por VIH: El síndrome retroviral agudo es la primera etapa de la infección por VIH. Se manifiesta clínicamente como un síndrome mononucleósico, que suele incluir fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga. A menudo se acompaña de un exantema rosado. En algunos casos, el síndrome retroviral agudo puede complicarse con meningitis aséptica, de tipo viral, con líquido cefalorraquídeo de predominio de células mononucleares y glucorraquia superior a 40 mg/dL. Durante el período de ventana, que es el tiempo que transcurre entre la infección por VIH y la aparición de anticuerpos detectables en la sangre, la serología para VIH puede ser negativa. Por lo tanto, el examen de elección para diagnosticar el síndrome retroviral agudo es la PCR para VIH o la detección de antígenos del VIH, ya que estas pruebas detectan directamente el virus. En cambio, en la infección crónica por VIH, el diagnóstico se realiza mediante serología (ELISA) y se confirma con Western blot, ya que en esta etapa los anticuerpos contra el VIH ya son detectables en la sangre.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)**

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En Chile, según la Ley 19.779 (Ley del SIDA), ningún examen de tamizaje local (sea test rápido o ELISA de 4ª generación) confiere diagnóstico definitivo. Ante cualquier resultado reactivo, se debe tomar una segunda muestra de sangre y enviarla al ISP para su confirmación oficial mediante Western Blot / Inmunocromatografía. Solo con el informe confirmatorio del ISP se entrega el diagnóstico al paciente y se activa la canasta GES.

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

**Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)**

1.04.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El esquema preferente de primera línea en las guías clínicas GES del MINSAL es la combinación en tableta única diaria de dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos (Tenofovir disoproxil fumarato + Lamivudina) asociados a un inhibidor de integrasa de segunda generación (Dolutegravir: TDF/3TC/DTG). Este esquema reemplazó a los regímenes antiguos basados en Efavirenz (asociados a efectos neuropsiquiátricos) y Zidovudina (asociada a mielotoxicidad y anemia severa).

**PREGUNTA 41** **Respuesta: D**

**Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA**

1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una mucormicosis clásica.

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

1.04.1.019, 1.04.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA**

En la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la presencia de una PaO2 < 70 mmHg o un gradiente alvéolo-arterial ≥ 35 mmHg define una forma moderada-severa con alto riesgo de falla ventilatoria. El uso de corticoides sistémicos (Prednisona 40 mg c/12h con pauta descendente por 21 días) reduce a la mitad la necesidad de intubación y la mortalidad intrahospitalaria, al mitigar la respuesta inflamatoria paradójica gatillada por la muerte del hongo.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: C**

1.04.1.019, 1.04.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA**

En un paciente con SIDA avanzado (CD4 < 100) que se presenta con múltiples lesiones cerebrales con realce en anillo y predilección por los núcleos de la base, la etiología más frecuente con gran diferencia es la Toxoplasmosis cerebral. La conducta recomendada internacionalmente es iniciar tratamiento empírico antitoxoplasma y repetir la neuroimagen en 10 a 14 días. La biopsia cerebral (A) solo se plantea si el paciente empeora clínicamente o no muestra mejoría radiológica tras 2 semanas (sospecha de Linfoma Primario del SNC).

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: B**

1.04.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR**

La sospecha es una tuberculosis vertebral, conocida como mal de Pox. Es una osteomieliGs, por lo que el examen de elección es la RMN. La cintigrafía es una opción, pero menos específica, por lo que ha sido desplazada por la RMN. La prueba ELISPOT es un IGRA (Interferon-Gamma Release Assay), que se usa en el diagnóstico de la TBC latente, al igual que el PPD y otros IGRAs.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

1.04.1.028, 1.04.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR**

Un líquido pleural exudativo con claro predominio mononuclear/linfocítico (> 80%) y una elevación de la enzima Adenosina Deaminasa (ADA) por encima de 40 UI/L tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 95% para Pleuritis Tuberculosa en áreas de prevalencia moderada como Chile. El empiema bacteriano (A) cursa con predominio PMN franco y pH < 7.20; la insuficiencia cardíaca (C) produce un trasudado con ADA normal (< 20 UI/L).

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

1.04.1.028, 1.04.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR**

La Rifampicina y sus metabolitos tienen una coloración rojo-anaranjada intrínseca que tiñe los fluidos corporales (orina, sudor, lágrimas y saliva). Este fenómeno es completamente inocuo, carece de significado patológico y no indica daño hepático ni renal. La conducta es educar y tranquilizar al paciente para asegurar la adherencia al tratamiento, advirtiendo a usuarios de lentes de contacto que estos pueden mancharse de forma permanente.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: D**

1.04.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas**

Es una sífilis secundaria clásica. Además recordar que el principal factor de riesgo para tener una ETS, es tener otra ETS.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

1.04.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas**

El paciente cursa con un secundarismo sifilítico (sífilis secundaria con exantema palmoplantar característico y títulos altos de VDRL). La sífilis secundaria forma parte de la Sífilis Precoz (menos de 1 año de evolución desde el contacto infectante). El tratamiento de elección normado por el MINSAL es Penicilina G Benzatina en DOSIS ÚNICA de 2.400.000 UI IM. El esquema de 3 semanas consecutivas (B) se reserva para sífilis latente tardía (> 1 año) o de duración indeterminada.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

1.04.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas**

La Penicilina es el ÚNICO antibiótico con eficacia demostrada para atravesar la placenta y tratar tanto a la madre como al feto, previniendo la sífilis congénita, el aborto y la muerte fetal in útero. La doxiciclina (A) está formalmente contraindicada en el embarazo por daño dental y óseo fetal. Los macrólidos (C) no cruzan adecuadamente la placenta. Por tanto, ante una embarazada alérgica a la penicilina, la norma nacional e internacional exige desensibilización protocolizada a penicilina y tratamiento posterior con Penicilina Benzatina.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: C**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH**

Pregunta difícil, ya que A, B, C y D pueden producir ese cuadro clínico. Sin embargo, la Chlamydia es la causa más frecuente de uretritis, después de la gonorrea (la que bastante purulenta, casi siempre; mientras que las demás pueden no serlo).

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH**

Aunque el frotis confirme gonorrea, el tratamiento sindrómico normado por el MINSAL y la CDC exige cobertura combinada para Neisseria gonorrhoeae (Ceftriaxona 500 mg IM dosis única) y Chlamydia trachomatis (Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días), debido a la frecuencia extrema de coinfección oculta. El ciprofloxacino (C) no se utiliza por alta resistencia de gonococo en Chile (> 50%).

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: C**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH**

La presencia de lesiones vesiculares agrupadas en racimo que evolucionan a úlceras superficiales dolorosas asociadas a adenopatías sensibles es el cuadro prototípico del primer episodio de Herpes Genital (generalmente por VHS-2). El tratamiento de elección para acortar el cuadro y reducir la eliminación viral es Aciclovir oral (400 mg cada 8 horas o 200 mg 5 veces al día por 7 a 10 días). El chancro sifilítico (B) es una úlcera única e indolora.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: A**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH**

Las cocáceas G(-) intracelulares son gonococo. Se debe tratar con ceftriaxona IM (259 mg por una vez), pero, además, se debe cubrir Chlamydia con doxiciclina o azitromicina o doxiciclina.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: E**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH**

Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

---

## BLOQUE 4 ZOONOSIS, MEDICINA TROPICAL Y VECTORES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: C** **Parasitosis intestinales** 1.04.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 25). Evalúa el manejo clínico de Parasitosis intestinales según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)**

Hantavirus pulmonar en Chile es transmitido por ratón colilargo. Fase cardiopulmonar: edema pulmonar no cardiogénico + leucopenia + trombocitopenia. Es la causa más probable en zona rural del sur.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)**

El cuadro corresponde a un Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus. En esta patología, la permeabilidad capilar alveolar está severamente aumentada por fuga endotelial; la administración de bolos masivos de volumen (como los 30 mL/kg típicos de la sepsis bacteriana) precipita un edema pulmonar masivo irreversible y asfixia al paciente. La guía clínica del MINSAL contraindica la resucitación agresiva con fluidos y exige manejo hemodinámico restrictivo.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B**

1.04.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)**

El virus Andes se transmite casi exclusivamente por vía aérea mediante la inhalación de polvo y aerosoles suspendidos en el aire provenientes de la saliva, orina o heces desecadas del roedor silvestre Oligoryzomys longicaudatus (ratón de cola larga), frecuentemente al realizar limpieza de cabañas, galpones o bodegas que han permanecido cerradas durante largo tiempo.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

1.04.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica**

En el recién nacido, los anticuerpos IgG atraviesan la placenta libremente, por lo que una serología IgG positiva solo refleja la infección materna y no confirma enfermedad en el niño. Por este motivo, la norma ministerial indica que el diagnóstico neonatal se realiza mediante métodos parasitológicos directos que buscan visualizar el parásito vivo en sangre (microhematocrito de sangre de cordón o capilar) o mediante PCR en centros de referencia.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

1.04.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica**

La coexistencia de megacolon (fase digestiva) y alteraciones de conducción cardíaca típicas como el bloqueo completo de rama derecha (fase cardíaca) en un paciente procedente de una zona endémica histórica de Chile (IV Región) es la presentación característica de la Enfermedad de Chagas en fase crónica determinada. Se debe confirmar con serología IgG (ELISA e IFI).

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: B**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla**

En los pacientes con sospecha de dengue, los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como Ketoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco) y el ácido acetilsalicílico (Aspirina) están terminantemente contraindicados debido a su acción antiagregante plaquetaria y al riesgo de gatillar hemorragias digestivas graves y potenciar el colapso hemodinámico en caso de evolución a dengue grave. El analgésico y antipirético de elección es el Paracetamol.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

1.04.1.008, 1.04.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla**

En los pacientes con sospecha de dengue, los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs como Ketoprofeno, Ibuprofeno, Diclofenaco) y el ácido acetilsalicílico (Aspirina) están terminantemente contraindicados debido a su acción antiagregante plaquetaria y al riesgo de gatillar hemorragias digestivas graves y potenciar el colapso hemodinámico en caso de evolución a dengue grave. El analgésico y antipirético de elección es el Paracetamol.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla**

1.04.1.008, 1.04.1.018 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Plasmodium vivax y Plasmodium ovale tienen la capacidad biológica de generar formas intrahepáticas durmientes denominadas hipnozoítos, las cuales no son eliminadas por la cloroquina (que solo actúa sobre las formas intraeritrocitarias sanguíneas). Para lograr la cura radical y evitar recaídas que pueden presentarse meses después, es mandatario administrar Primaquina por 14 días, previa verificación de niveles normales de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD).

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: C**

**Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla**

1.04.1.018 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Pregunta muy difícil, en especial porque es muy infrecuente la malaria por P. falciparum en América, incluyendo la Amazonía. Sin embargo, la presencia de anemia marcada hace que el diagnóstico sea malaria y no las demás opciones. La clínica es compatible también con el dengue. El virus Zika puede tener la misma clínica, pero suele ser menos intensa; a la fiebre amarilla le falta la ictericia; a la fiebre tifoidea le falta la diarrea.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis**

1.04.1.013 | Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Es un quiste hidatídico con el patrón ecográfico clásico (lesión quística con paredes y/o tabiques). El diagnóstico se confirmó ya con la Ecografía, pero la serología puede ayudar a confirmarlo y además sirve para el seguimiento postquirúrgico (en que deben disminuir los niveles de anticuerpos). Además, era la única opción relacionada con el diagnóstico.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: A**

**Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis**

1.04.1.013, 1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El antecedente del consumo de carne o embutidos de cerdo no fiscalizados sumado a la tríada de fiebre, edema bipalpebral y mialgias con hipereosinofilia marcada (> 30%) es patognomónico de Triquinosis (infección por Trichinella spiralis). La hidatidosis (B) no cursa con este cuadro muscular agudo ni con edema bipalpebral; el Chagas agudo (E) produce el signo de Romaña que es típicamente UNILATERAL.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

**Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis**

1.04.1.013, 1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El hallazgo ecográfico del signo del camalote es característico de un quiste hidatídico hepático por Echinococcus granulosus. La complicación aguda más temida y de riesgo vital inminente es la rotura del quiste (sea espontánea por aumento de presión intracística o traumática tras un golpe menor), lo cual libera líquido hidatídico rico en antígenos altamente alergénicos hacia el peritoneo, desencadenando un shock anafiláctico fulminante y siembra peritoneal difusa de protoescólices.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis**

1.04.1.027 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene una triquinosis clásica: mialgias + eosinofilia + CK elevadas. Puede afectar el corazón y otros órganos. Se trata con analgésicos más albendazol o mebendazol. Si hay signos de gravedad (ej. miocardiGs de este caso), se agregan corticoides.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

**Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea**

1.04.1.004 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 6). Evalúa el manejo clínico de Brucelosis según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

1.04.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea**

Aunque el cuadro clínico es algo inespecífico, el hemograma con leucopenia, algo de desviación izquierda y aeosinofilia es el clásico “hemograma Vfico”.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea**

El antecedente de contacto con aguas estancadas y alcantarillados sumado al cuadro de fiebre, mialgias exquisitas en las pantorrillas y el signo patognomónico de sufusión conjuntival bilateral sin pus, que progresa a falla multiorgánica con ictericia severa y falla renal aguda (Síndrome de Weil), es diagnóstico de Leptospirosis grave por Leptospira interrogans. La hepatitis A (B) y la colangitis (C) no cursan con sufusión conjuntival ni dolor marcado en pantorrillas.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

1.04.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)**

La presentación clínica de una escara necrótica negruzca indolora con vesículas satélites y edema masivo en un trabajador expuesto a cueros o lanas animales es característica de carbunco cutáneo (Ántrax). El tratamiento antibiótico de elección recomendado internacionalmente por su alta efectividad y cobertura frente a cepas naturales y de bioseguridad es Ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 h) o alternativamente Doxiciclina.

---

## BLOQUE 5 INFECCIONES COMUNITARIAS, EXANTEMAS Y HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Adenitis, adenoflegmón** 1.04.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Adenitis, adenoflegmón" (1.04.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: E** **Influenza** 1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta demasiado discutible, ya que los pacientes sin antecedentes de riesgo tienen la opción de usar oseltamivir, si así lo quieren, para disminuir el tiempo de influenza y asegurar que no será grave. La guía minsal solo da oseltamivir a pacientes con factores de riesgo o con influenza grave. Sin embargo el tratamiento sintomático es el de elección en la influenza. Se debe evitar la aspirina y el ibuprofeno, por el riesgo de síndrome de Reye. Además por la rinorrea y congestión, se puede sospechar otro virus, distinto a la influenza

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: C** **Osteomielitis** 1.04.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tratamiento de Staphylococcus aureus Resistente a la Meticilina: Un antibiograma que muestra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), siendo resistente a los betalactámicos en general, incluyendo oxacilina y cefalosporinas. El tratamiento de elección para el SARM es la vancomicina.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: E**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis**

Parece una infección de una herida abrasiva. Como los bordes son parcialmente definidos, no queda claro si es una celulitis o una erisipela. Afortunadamente el cefa-

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis**

La presencia de una placa eritematosa con bordes nítidos, claramente delimitados y sobreelevados es la descripción clásica de la erisipela, la cual es producida en más del 90% de los casos por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A). La celulitis por S. aureus o Gram negativos produce bordes planos y difusos.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

1.04.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis**

En la celulitis comunitaria no complicada, los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus meticilino-sensible y Streptococcus pyogenes. El tratamiento oral de primera línea de elección en Chile son las cefalosporinas de primera generación (Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cefalexina 500 mg c/6h) o las penicilinas isoxazólicas (Flucloxacilina 500 mg c/8h), por su excelente perfil de eficacia y tolerancia.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: D**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH**

Tiene una mononucleosis clásica, con el síndrome mononucleósico (odinofagia, adenopaVas y fiebre), más los elementos clásicos: linfocitosis, hepatoesplenomegalia y hepaGGs (faltó el rash morbiliforme espontáneo o posterior al uso de aminopenicilinas).

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: B**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH**

La tríada de faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia asociada a la aparición de un exantema eritematoso difuso tras la ingesta de amoxicilina es patognomónica de Mononucleosis Infecciosa por Virus Epstein-Barr (VEB). La amoxicilina induce este rash en más del 90% de los pacientes infectados por VEB por alteración de la respuesta celular inmune.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

1.04.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH**

El Citomegalovirus (CMV) es la infección congénita más frecuente del complejo TORCH. Su hallazgo radiológico patognomónico son las calcificaciones en la zona subependimaria periventricular, y es la principal causa no genética de hipoacusia neurosensorial infantil. Toxoplasma (A) causa calcificaciones intraparenquimatosas difusas y coriorretinitis.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: C**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki**

Es una varicela en mayor de 13 años. La aspirina está contraindicada.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki**

El cuadro corresponde a Escarlatina, producida por cepas de Streptococcus pyogenes productoras de toxina eritrogénica. Para asegurar la erradicación bacteriana faríngea y prevenir complicaciones no supurativas tardías (especialmente la Fiebre Reumática aguda), la norma nacional e internacional exige administrar Amoxicilina oral durante 10 días completos (o alternativamente Penicilina Benzatina IM en dosis única). Pautas más cortas fracasan en prevenir la fiebre reumática.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki**

La complicación más temida de la Enfermedad de Kawasaki es la vasculitis coronaria, que sin tratamiento conduce a la formación de aneurismas coronarios en hasta el 25% de los pacientes, con riesgo subsecuente de infarto agudo de miocardio infantil y muerte súbita. La administración de IGEV (2 g/kg) en los primeros 10 días de evolución reduce esta incidencia a menos del 3-5%, siendo el pilar terapéutico cardioprotector indiscutido.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

1.04.1.011, 1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster**

La neumonitis varicelosa es una complicación potencialmente mortal típica del adulto joven. El tratamiento de elección indiscutido es Aciclovir por vía ENDOVENOSA a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La vía oral (B) es insuficiente debido a su baja biodisponibilidad (15-20%) y no logra concentraciones pulmonares terapéuticas suficientes para frenar la replicación viral en el pulmón. La inmunoglobulina (D) solo sirve para profilaxis post-exposición precoz, no para tratar la enfermedad establecida.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A**

1.04.1.011, 1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster**

El cuadro corresponde a un Herpes Zóster Oftálmico que afecta la rama nasociliar del nervio oftálmico (V1 del trigémino), evidenciado por el signo de Hutchinson (vesículas en la punta de la nariz). Esta manifestación predice afectación corneal severa (queratitis dendrítica, uveítis anterior, glaucoma secundario y riesgo de pérdida visual irreversible). La conducta inmediata consiste en iniciar Aciclovir oral (800 mg 5 veces al día) o Valaciclovir y derivar de forma urgente al especialista en Oftalmología para examen con lámpara de hendidura.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

1.04.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster**

La neumonitis varicelosa es una complicación potencialmente mortal típica del adulto joven. El tratamiento de elección indiscutido es Aciclovir por vía ENDOVENOSA a dosis de 10 mg/kg cada 8 horas durante 7 a 10 días. La vía oral (B) es insuficiente debido a su baja biodisponibilidad (15-20%) y no logra concentraciones pulmonares terapéuticas suficientes para frenar la replicación viral en el pulmón. La inmunoglobulina (D) solo sirve para profilaxis post-exposición precoz, no para tratar la enfermedad establecida.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

1.04.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco**

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

1.04.1.020, 1.04.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco**

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.

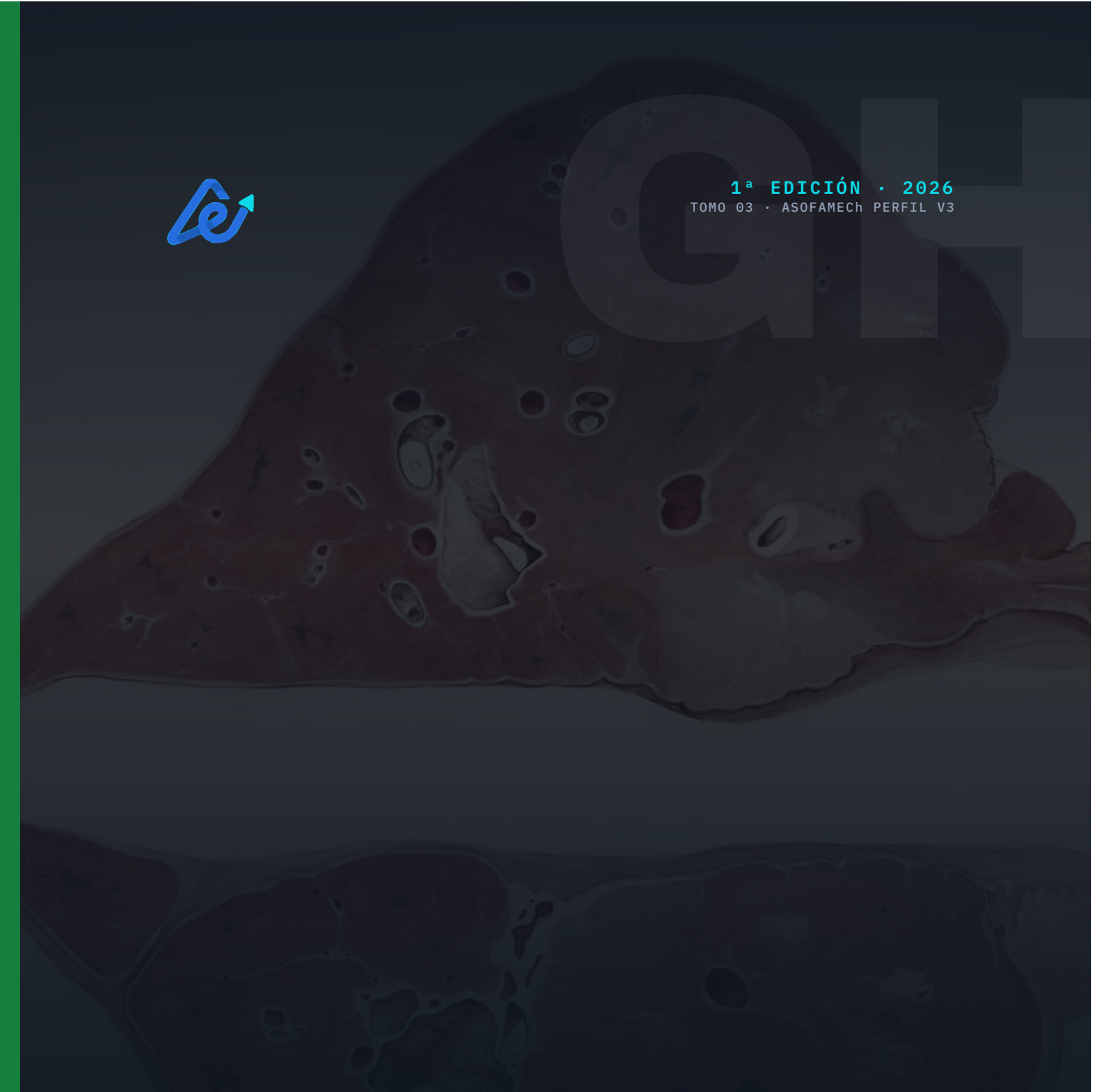
---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

1.04.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco**

El paciente cursa con una neutropenia febril de alto riesgo (RAN < 500 en contexto de leucemia mieloide aguda). La recomendación Surviving Sepsis y las guías internacionales de neutropenia febril exigen el inicio inmediato de antibioterapia antipseudomónica endovenosa de amplio espectro (tiempo puerta-aguja < 60 minutos), siendo Cefepime 2 g c/8h EV (o Piperacilina-Tazobactam) el fármaco de elección. Ceftriaxona (B) no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa, el germen más letal en este escenario.



1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 03 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# GASTROENTEROLOGÍ

## 90 Preguntas de Práctica

Hepatología

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Gastroenterología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ESÓFAGO Y ESTÓMAGO** | | | | | |
| 1.06.1.002 | Cáncer de páncreas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 03 · C.2 (Pág. 8) |
| 1.06.1.004 | Cáncer gástrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2, Q17, Q18 | Tomo 03 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.06.1.011 | Diarrea crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 03 · C.10 (Pág. 24) |
| 1.06.1.013 | Disfagia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4, Q13, Q14 | Tomo 03 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.06.1.016 | Enfermedad diverticular complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.027 | Reflujo gastroesofágico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q6, Q9, Q10 | Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.06.1.030 | Úlcera péptica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q7, Q11, Q12 | Tomo 03 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.06.2.002 | Afagia aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q8, Q15, Q16 | Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11) |
| **BLOQUE 2: INTESTINO Y COLON** | | | | | |
| 1.06.1.008 | Trastornos digestivos funcionales | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q29, Q30 | Tomo 03 · 2.1 (Pág. 20) |
| 1.06.1.012 | Diarrea en inmunosuprimidos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.015 | Enfermedad celiaca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q21, Q33, Q34 | Tomo 03 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.06.1.017 | Enfermedad diverticular no complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q22 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.018 | Enfermedad inflamatoria intestinal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23, Q35, Q36 | Tomo 03 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.06.1.023 | Intolerancia a la lactosa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q24 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.026 | Parasitosis intestinales | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q25 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.028 | Síndrome de malabsorción | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q26 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.1.029 | Tumores de colon | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q27 | Tomo 03 · 2.5 (Pág. 28) |
| 1.06.2.005 | Diarrea aguda | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q28, Q31, Q32 | Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22) |
| **BLOQUE 3: HÍGADO** | | | | | |
| 1.06.1.001 | Ascitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 03 · C.4 (Pág. 12) |
| 1.06.1.005 | Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 03 · 3.3 (Pág. 39) |
| 1.06.1.007 | Colestasia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38, Q49, Q50 | Tomo 03 · 3.1 (Pág. 35) |
| 1.06.1.019 | Hepatitis aguda A no complicada | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q39, Q51, Q52, Q53 | Tomo 03 · 3.2 (Pág. 37) |
| 1.06.1.020 | Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.021 | Hepatitis crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.022 | Insuficiencia hepática crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.024 | Masa hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 03 · 3.4 (Pág. 41) |
| 1.06.2.006 | Encefalopatía hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.008 | Hepatitis aguda A complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.009 | Insuficiencia hepática aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.011 | Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q47 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.012 | Síndrome hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: VÍA BILIAR Y PÁNCREAS** | | | | | |
| 1.06.1.003 | Cáncer de vesícula y vías biliares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57 | Tomo 03 · C.3 (Pág. 10) |
| 1.06.1.006 | Colelitiasis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q69, Q70 | Tomo 03 · 4.1 (Pág. 46) |
| 1.06.1.010 | Diarrea asociada a antibióticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 03 · C.9 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.1.025 | Pancreatitis crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.003 | Colangitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q66 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.004 | Colecistitis aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q67 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.010 | Pancreatitis aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q68, Q71, Q72 | Tomo 03 · 4.2 (Pág. 48) |
| **BLOQUE 5: ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS** | | | | | |
| 1.01.1.001 | Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89, Q90 | Tomo 01 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.06.1.009 | Constipación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 03 · C.8 (Pág. 20) |
| 1.06.1.014 | Dispepsia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.027 | Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q87, Q88 | Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.06.2.001 | Abdomen agudo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 03 · 5.1 (Pág. 53) |
| 1.06.2.002 | Cuerpo Extraño Digestivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83, Q84 | Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.06.2.005 | Diarrea Aguda y Crónica en el Niño | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86 | Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22) |
| 1.06.2.007 | Hemorragia digestiva alta y baja | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76, Q81, Q82 | Tomo 03 · 5.3 (Pág. 57) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Gastroenterología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.001 | Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89, Q90 | Tomo 01 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.06.1.001 | Ascitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 03 · C.4 (Pág. 12) |
| 1.06.1.002 | Cáncer de páncreas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 03 · C.2 (Pág. 8) |
| 1.06.1.003 | Cáncer de vesícula y vías biliares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57 | Tomo 03 · C.3 (Pág. 10) |
| 1.06.1.004 | Cáncer gástrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2, Q17, Q18 | Tomo 03 · 1.5 (Pág. 13) |
| 1.06.1.005 | Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 03 · 3.3 (Pág. 39) |
| 1.06.1.006 | Colelitiasis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q69, Q70 | Tomo 03 · 4.1 (Pág. 46) |
| 1.06.1.007 | Colestasia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38, Q49, Q50 | Tomo 03 · 3.1 (Pág. 35) |
| 1.06.1.008 | Trastornos digestivos funcionales | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q29, Q30 | Tomo 03 · 2.1 (Pág. 20) |
| 1.06.1.009 | Constipación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 03 · C.8 (Pág. 20) |
| 1.06.1.010 | Diarrea asociada a antibióticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 03 · C.9 (Pág. 22) |
| 1.06.1.011 | Diarrea crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 03 · C.10 (Pág. 24) |
| 1.06.1.012 | Diarrea en inmunosuprimidos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.013 | Disfagia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4, Q13, Q14 | Tomo 03 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.06.1.014 | Dispepsia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.015 | Enfermedad celiaca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q21, Q33, Q34 | Tomo 03 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.06.1.016 | Enfermedad diverticular complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.1.017 | Enfermedad diverticular no complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q22 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.018 | Enfermedad inflamatoria intestinal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23, Q35, Q36 | Tomo 03 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.06.1.019 | Hepatitis aguda A no complicada | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q39, Q51, Q52, Q53 | Tomo 03 · 3.2 (Pág. 37) |
| 1.06.1.020 | Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.021 | Hepatitis crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.022 | Insuficiencia hepática crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.023 | Intolerancia a la lactosa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q24 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.024 | Masa hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 03 · 3.4 (Pág. 41) |
| 1.06.1.025 | Pancreatitis crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.026 | Parasitosis intestinales | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q25 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.027 | Reflujo gastroesofágico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q6, Q9, Q10, Q87, Q88 | Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.06.1.028 | Síndrome de malabsorción | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q26 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.1.029 | Tumores de colon | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q27 | Tomo 03 · 2.5 (Pág. 28) |
| 1.06.1.030 | Úlcera péptica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q7, Q11, Q12 | Tomo 03 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.06.2.001 | Abdomen agudo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 03 · 5.1 (Pág. 53) |
| 1.06.2.002 | Afagia aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q8, Q15, Q16, Q83, Q84 | Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11) |
| 1.06.2.003 | Colangitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q66 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.004 | Colecistitis aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q67 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.005 | Diarrea aguda | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q28, Q31, Q32, Q85, Q86 | Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.006 | Encefalopatía hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.007 | Hemorragia digestiva alta y baja | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76, Q81, Q82 | Tomo 03 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.06.2.008 | Hepatitis aguda A complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.009 | Insuficiencia hepática aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.010 | Pancreatitis aguda | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q68, Q71, Q72 | Tomo 03 · 4.2 (Pág. 48) |
| 1.06.2.011 | Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q47 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |
| 1.06.2.012 | Síndrome hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

PREGUNTA 1 1.06.1.002

**1. Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como antecedente, es hipertenso y fumador de 5 paquetes-año. Su examen Fsico muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones en el examen abdominal. Se solicitan pruebas hepá8cas que muestran SGOT: 72 U/L, SGPT: 48 U/L, GGT: 115 U/L, fosfatasa alcalina 200: U/L y bilirrubina: 4,9 mg/dL, de predominio directo. Se realiza ecograFa abdominal que muestra vesícula biliar dilatada de 16 × 8 cm y dilatación de la vía biliar intrahepá8ca y extrahepá8ca. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Tumor de páncreas
B) Colangiocarcinoma
C) Colangi2s esclerosante primaria
D) Diveraculo duodenal
E) Colangi2s infecciosa

PREGUNTA 2 1.06.1.004

**2. Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpal el epigastrio. Además en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?**

A) Endoscopía digestiva alta
B) pH-metría de 24 horas
C) TAC de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Marcadores tumorales

PREGUNTA 3 1.06.1.011

**3. Una paciente de 53 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?**

A) Endoscopía digestiva alta, con biopsia de duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Colonoscopía
D) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
E) Test de sangre oculta en deposiciones

PREGUNTA 4 1.06.1.013

**4. Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer esofágico
B) Reflujo gastroesofágico
C) Acalasia
D) Candidiasis esofágica
E) Divertículo esofágico

PREGUNTA 5 1.06.1.016

**5. Un paciente se realiza una colonoscopía, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?**

A) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
B) Ecografía abdominal y pélvica
C) Colonoscopía
D) Radiografía de abdomen y pelvis
E) TAC de abdomen y pelvis

PREGUNTA 6 1.06.1.027

**6. Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:**

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Solicitar pH-metría esofágica
C) Indicar inhibidores de la bomba de protones
D) Solicitar manometría esofágica
E) Cambiar a antihistamínicos H2

PREGUNTA 7 1.06.1.030

**7.** **Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopía digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
B) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar nueva endoscopía digestiva alta con test de ureasa
D) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
E) Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.

PREGUNTA 8 1.06.2.002

**8.** **Disfagia a nivel de xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso de agua. Conducta:**

A) EDA
B) Radiografía
C) Nasolaringoscopia
D) Manometría esofágica
E) Derrame pleural

PREGUNTA 9 1.06.1.027

**9.** **Hombre de 27 años, sin antecedentes, consulta por 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y el estrés, con pirosis ocasional. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera duodenal activa y el test de ureasa resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina por 14 días
B) Indicar omeprazol y repetir la endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar una nueva endoscopía con test de ureasa
D) Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia
E) Indicar solo omeprazol por 8 semanas y control clínico

PREGUNTA 10 1.06.1.027

**10.** **Paciente con úlcera gástrica y test de ureasa positivo recibe amoxicilina, claritromicina y omeprazol por 10 días, seguido de omeprazol por 4 semanas. El control con test de ureasa a las 6 semanas post-tratamiento sigue positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el mismo esquema por 14 días
B) Realizar endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Indicar terapia erradicadora de segunda línea
D) Repetir el test de ureasa en 3 meses
E) Observar la evolución clínica

PREGUNTA 11 1.06.1.030

**11.** **Hombre de 40 años con úlcera duodenal en la endoscopía. El test de ureasa para H. pylori resulta negativo. No usa AINE. ¿Cuál es la conducta respecto de la erradicación?**

A) No erradicar, porque el test de H. pylori es negativo
B) Erradicar igualmente con esquema de primera línea
C) Indicar solo omeprazol por 6 semanas
D) Repetir la endoscopía en 4 semanas antes de decidir
E) Solicitar antígeno fecal y erradicar solo si es positivo

PREGUNTA 12 1.06.1.030

**12.** **Mujer de 35 años con epigastralgia urente de 2 meses, sin baja de peso, anemia ni disfagia. La endoscopía digestiva alta es completamente normal y el test de H. pylori es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?**

A) Úlcera péptica; iniciar terapia de erradicación
B) Cáncer gástrico incipiente; repetir endoscopía con cromoendoscopia
C) Dispepsia funcional; educación, manejo del estrés y prueba con IBP
D) Gastroparesia; solicitar cintigrafía de vaciamiento gástrico
E) ERGE; iniciar IBP a permanencia y cirugía antirreflujo

PREGUNTA 13 1.06.1.013

**13.** **Hombre de 62 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 3 meses de disfagia que comenzó con la carne y el pan y ahora también le cuesta tragar líquidos, con baja de 7 kg de peso. ¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Manometría esofágica
B) Esofagograma con bario
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia
D) TAC de tórax con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

PREGUNTA 14 1.06.1.013

**14.** **Mujer de 71 años consulta por sensación de que la comida "se le queda en la garganta" desde hace un año, regurgitación de alimentos no digeridos y halitosis intensa que le notan sus familiares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de esófago
B) Acalasia
C) Divertículo de Zenker
D) Esclerodermia esofágica
E) Estenosis péptica por reflujo

PREGUNTA 15 1.06.2.002

**15.** **Niño de 3 años que hace 2 horas bebió un sorbo de soda cáustica del envase mal rotulado. Presenta sialorrea y llanto al tragar, sin dificultad respiratoria. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Lavado gástrico con sonda nasogástrica
B) Carbón activado por vía oral
C) Endoscopía digestiva alta en las primeras horas
D) Administrar leche o vinagre diluido para neutralizar
E) Provocar el vómito y observar

PREGUNTA 16 1.06.2.002

**16.** **Hombre de 45 años, tras una cena copiosa con alcohol y varios episodios de vómitos, presenta dolor torácico intenso y, al examen, crepitación a la palpación del cuello. Está febril y taquicárdico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Mallory-Weiss
B) Perforación esofágica (síndrome de Boerhaave)
C) Infarto agudo de miocardio
D) Neumotórax espontáneo
E) Disección aórtica

PREGUNTA 17 1.06.1.004

**17. Hombre de 60 años consulta por baja de 8 kg de peso en 3 meses, epigastralgia sorda e hiporexia. No tiene ictericia. ¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste
B) Endoscopía digestiva alta con biopsias
C) Ecografía abdominal
D) Marcadores tumorales (CEA, CA 19-9)
E) Tránsito esofagogastroduodenal con bario

PREGUNTA 18 1.06.1.004

**18. Mujer de 55 años con endoscopía por dispepsia que informa un adenocarcinoma gástrico limitado a la mucosa, sin invasión de la submucosa, en una lesión de 15 mm bien diferenciada y sin úlcera. El TAC no muestra adenopatías ni metástasis. ¿Qué define el pronóstico y cuál es la conducta?**

A) El tamaño de la lesión; observación con endoscopías seriadas
B) La profundidad de invasión de la pared; resección (endoscópica o quirúrgica) con intención curativa
C) La presencia de H. pylori; solo terapia de erradicación
D) El grado de diferenciación; quimioterapia paliativa
E) El nivel de CEA; radioterapia externa

## BLOQUE 2 INTESTINO Y COLON

PREGUNTA 19 1.06.1.008

**19. Una paciente de 45 años consulta por dolor abdominal de 4 meses de evolución, caracterizado por malestar abdominal difuso con exacerbaciones cólicas, que ha tenido una intensidad variable y que se asocia a deposiciones de consistencia dura, 8po Bristol 2, que se presentan cada 4 a 5 días, tras las cuales el dolor disminuye considerablemente. Sin embargo, también ha presentado episodios de diarrea de manera esporádica. Su examen Fsico muestra abdomen blando, sensible, sin masas, visceromegalia ni signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Síndrome de intes2no irritable con predominio de cons2pación
B) Enfermedad celíaca
C) Coli2s ulcerosa
D) Cáncer de colon
E) Cons2pación funcional

PREGUNTA 20 1.06.1.012

**20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diarrea en inmunosuprimidos · 1.06.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diarrea en inmunosuprimidos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 1.06.1.015

**21. Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Se solicitan exámenes, entre los que destaca anemia ferropénica. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Parasitosis intestinal
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Enfermedad de Cröhn
E) Enteropatía perdedora de proteínas

PREGUNTA 22 1.06.1.017

**22. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad diverticular no complicada · 1.06.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad diverticular no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 23 1.06.1.018

**23. Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor abdominal periumbilical y fístula perianal. Colonoscopía: úlceras aftosas con mucosa normal entre ellas (patrón en empedrado). ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Síndrome de intestino irritable
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Crohn
D) Tuberculosis intestinal
E) Linfoma intestinal

PREGUNTA 24 1.06.1.023

**24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Intolerancia a la lactosa · 1.06.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Intolerancia a la lactosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 1.06.1.026

**25. [ATENCIÓN PRIMARIA: Parasitosis intestinales · 1.06.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Parasitosis intestinales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 26 1.06.1.028

**26. Una paciente de 40 años consulta por deposiciones frecuentes y diarrea de 3 meses de evolución. Presenta urgencia defecatoria, especialmente tras ingerir alimentos ricos en grasa, y nota gotas de grasa flotando en el inodoro, luego de defecar. Adicionalmente, refiere baja de peso no cuan8ficada. Su examen Fsico muestra signos vitales normales y su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales ni masas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Enfermedad celíaca
B) Insuficiencia pancreá2ca exocrina
C) Sobrecrecimiento bacteriano
D) Coli2s ulcerosa
E) Giardiasis

PREGUNTA 27 1.06.1.029

**27. Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?**

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Ecografía abdominal
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía
E) Rectosigmoidoscopía

PREGUNTA 28 1.06.2.005

**28. Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar: 37,1 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, presenta dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa iliaca derecha. No tiene signo de Blumberg. Se solicita una ecografía abdominal que muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho y se ve el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. ¿Cuál es el**

A) Apendicitis aguda
B) Enteritis infecciosa
C) Diverticulitis aguda
D) Enfermedad de Cröhn
E) Colitis isquémica

PREGUNTA 29 1.06.1.008

**29. Mujer de 48 años consulta por distensión y dolor abdominal de 1 año, alternando diarrea y constipación. En los últimos 2 meses refiere deposiciones más frecuentes, baja de 4 kg de peso no buscada y un episodio de rectorragia. Su madre tuvo cáncer de colon a los 55 años. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Diagnosticar síndrome de intestino irritable e iniciar dieta baja en FODMAP
B) Solicitar colonoscopía
C) Indicar antiespasmódicos y control en 3 meses
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones y repetir en 1 año
E) Iniciar amitriptilina en dosis baja

PREGUNTA 30 1.06.1.008

**30. Hombre de 29 años consulta por dolor abdominal recurrente de 6 meses que alivia al defecar, asociado a deposiciones más blandas cuando aparece el dolor. Sin baja de peso, anemia ni antecedentes familiares. Hemograma, PCR y anticuerpos anti-transglutaminasa normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Colonoscopía para descartar enfermedad inflamatoria intestinal
B) Diagnóstico de síndrome de intestino irritable e iniciar manejo
C) Endoscopía digestiva alta con biopsias duodenales
D) TAC de abdomen y pelvis con contraste
E) Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones

PREGUNTA 31 1.06.2.005

**31. Hombre de 46 años presenta diarrea líquida de 3 semanas que comenzó 10 días después de terminar un tratamiento con amoxicilina-clavulánico por una neumonía. Sin sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la etiología?**

A) Coprocultivo corriente
B) PCR de toxina para Clostridioides difficile en deposiciones
C) Parasitológico seriado de deposiciones
D) Colonoscopía con biopsias
E) Calprotectina fecal

PREGUNTA 32 1.06.2.005

**32. Niño de 2 años con diarrea acuosa de 2 días y fiebre de 38,5 °C, sin sangre en las deposiciones, con buen estado general y sin signos de deshidratación. ¿Cuál es la conducta respecto de los antibióticos?**

A) Ciprofloxacino oral
B) Ceftriaxona endovenosa
C) Azitromicina oral
D) No indicar antibióticos
E) Metronidazol oral

PREGUNTA 33 1.06.1.015

**33. Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste con diarrea y baja de peso. Los anticuerpos anti-transglutaminasa están negativos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?**

A) Transgresión oculta de la dieta
B) Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)
C) Intolerancia a la lactosa secundaria
D) Síndrome de intestino irritable sobreagregado
E) Giardiasis crónica

PREGUNTA 34 1.06.1.015

**34. Recién nacido de 12 días con ictericia prolongada, hepatomegalia, mal incremento ponderal y cataratas bilaterales detectadas en el examen ocular. ¿Cuál es el tratamiento nutricional indicado?**

A) Mantener lactancia materna exclusiva
B) Fórmula sin lactosa
C) Fórmula de soya (sin galactosa)
D) Fórmula extensamente hidrolizada
E) Suplemento oral de lactasa con leche materna

PREGUNTA 35 1.06.1.018

**35. Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y bajó 4 kg. La colonoscopía muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad de Crohn
C) Colitis isquémica
D) Parasitosis intestinal
E) Colitis por Clostridioides difficile

PREGUNTA 36 1.06.1.018

**36. Paciente de 45 años con antecedente de colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace una semana presenta deposiciones blandas con escasa sangre. El examen físico no aporta información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar rectosigmoidoscopía
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar parasitológico de deposiciones
D) Solicitar colonoscopía
E) Iniciar corticoides orales

## BLOQUE 3 HÍGADO

PREGUNTA 37 1.06.1.001

**37.** **Un paciente fumador de 20 paquetes-año, que consume cerca de 5 g de alcohol al día los fines de semana, presenta moles8as abdominales inespecíficas y distensión abdominal progresiva desde hace 3 meses, a lo que en el úl8mo 8empo se agregó dolor abdominal. Se observa el paciente enflaquecido, con FC: 70x', PA: 130/80 mmHg y, en el examen abdominal, se constata asci8s a tensión, sin circulación colateral. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT: 48 U/L, GPT: 37 U/L, GGT: 59 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, protrombinemia: 80% y albuminemia: 2,9 g/dL. Además, se realiza paracentesis diagnós8ca que muestra líquido ascí8co con 680 células/mm³, 80% mononucleares y 20% polimorfonucleares, glucosa: 116 mg/dL, proteínas: 1,36 g/dL y ADA: 3,4 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Peritoni2s bacteriana espontánea
B) Asci2s por hipertensión portal
C) Síndrome nefró2co
D) Tuberculosis peritoneal
E) Carcinomatosis peritoneal

PREGUNTA 38 1.06.1.007

**38.** **Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A) Colestasia por esteatosis hepática
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por compresión externa
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

PREGUNTA 39 1.06.1.019

**39.** **Un paciente de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, que es seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está ictérico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis alcohólica
D) Colédocolitiasis
E) Fiebre tifoidea

PREGUNTA 40 1.06.1.020

**40.** **Una paciente de 20 años, en tratamiento con isotretinoína, desde hace 10 días, por acné, consulta por dolor abdominal, asociada a malestar general y astenia, a lo que se ha agregado ictericia y orinas oscuras. En su examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen se palpa bando, doloroso en epigastrio e hipocondrio, con hígado palpable 3 cm por debajo del reborde costal. Sus pruebas hepáticas resultan GOT: 328 UI/L, GPT: 459 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, FA: 80 UI/L, GGT: 92 UI/L, protrombinemia: 80%. Además, se solicita serología que muestra IgG(+)VHA, IgM(-)VHA, Antígeno VHBs(-), Anticuerpos totales antiHBVc(+). Anticuerpos anti-VHC y marcadores de autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por drogas
E) Hepatitis autoinmune

PREGUNTA 41 1.06.1.021

**41.** **Un paciente asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 432 UI/L y SGPT: 310 UI/L. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?**

A) Antígeno de superficie de VHB
B) IgM para VHA
C) Test de HOMA
D) Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo
E) Anticuerpos totales contra VHC

PREGUNTA 42 1.06.1.022

**42.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia hepática crónica · 1.06.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia hepática crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 43 1.06.1.024

**43.** **Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml) El diagnóstico más probable es:**

A) Metastásis hepática
B) Adenoma hepático
C) Carcinoma hepatocelular
D) Quiste hepático
E) Hemangioma hepático

PREGUNTA 44 1.06.2.006

**44.** **Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol, presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico presenta ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?**

A) Amonio
B) N-acetil-cisteína
C) Risperidona
D) Donepezilo
E) Lactulosa

PREGUNTA 45 1.06.2.008

**45.** **Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por astenia, fiebre, malestar general y dolor epigástrico. Hace dos días se agregó ictericia de piel y escleras el día de hoy presentó orinas oscuras. Al examen físico tiene FC: 96x', PA: 100/60 mmHg, con ictericia franca en escleras y piel, sin alteraciones en el nivel de conciencia. En el examen abdominal se observa dolor a la palpación epigástrica y del hipocondrio derecho, sin signos peritoneales ni visceromegalia; los ruidos hidroaéreos están conservados. Se solicitan exámenes, que muestran GOT: 2.640 UI/L, GPT: 2.860 UI/L, GGT: 180 UI/L, FA: 412 UI/L, protrombinemia: 52%, bilirrubina total: 9,2 mg/dl, fracción directa: 6,6 mg/dl, albúmina plasmática: 3,4 g/dl. Se solicita IgM para virus hepatitis A, que resulta 5,5 UI (VN: menor a 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar ambulatoriamente
D) Solicitar una colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E) Indicar N-acetil-cisteína oral

PREGUNTA 46 1.06.2.009

**46.** **[URGENCIA: Insuficiencia hepática aguda · 1.06.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia hepática aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 1.06.2.011

**47.** **Una paciente de 55 años, con antecedente de daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por cuadro de malestar general, asociado a febrículas, confusión y aumento de perímetro abdominal. Al examen abdominal destaca matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica que muestra transudado y presencia de 300 leucocitos (100% polimorfonucleares). La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Administrar albúmina endovenosa
B) Realizar paracentesis evacuadora
C) Observar
D) Administrar antibióticos de forma empírica
E) Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

PREGUNTA 48 1.06.2.012

**48.** **[URGENCIA: Síndrome hepatorrenal · 1.06.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome hepatorrenal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 1.06.1.007

**49.** **Estudiante de 22 años, asintomático, consulta porque en un examen preventivo le encontraron una bilirrubina total de 2,6 mg/dL, a expensas de la indirecta. Las transaminasas, fosfatasas alcalinas, GGT, hemograma y LDH son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A) Hepatitis viral aguda; solicitar serología viral y control seriado
B) Anemia hemolítica; frotis y test de Coombs
C) Síndrome de Gilbert; tranquilizar y no requiere tratamiento
D) Coledocolitiasis; ecografía abdominal urgente
E) Cirrosis biliar primaria; anticuerpos antimitocondriales

PREGUNTA 50 1.06.1.007

**50.** **Mujer de 55 años con dolor cólico en el hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Laboratorio: bilirrubina 4 mg/dL de predominio directo, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas, transaminasas levemente altas. La ecografía muestra colelitiasis y una vía biliar de 9 mm, sin visualizar cálculos en el colédoco. ¿Cuál es el siguiente examen?**

A) CPRE directa
B) Colangiorresonancia
C) TAC de abdomen con contraste
D) Biopsia hepática percutánea
E) Repetir la ecografía en 48 horas

PREGUNTA 51 1.06.1.019

**51.** **Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB (AgHBs) negativo y anticuerpos anti-HBs (antisuperficie) positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Vacunada contra la hepatitis B
B) Hepatitis B aguda
C) Hepatitis B crónica
D) Hepatitis B en período de ventana
E) Infección asintomática por virus hepatitis B

PREGUNTA 52 1.06.1.019

**52.** **Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días se agregó ictericia y hoy orinas oscuras. Al examen: FC 96/min, PA 100/60, ictericia franca, sin compromiso de conciencia, dolor en epigastrio e hipocondrio derecho sin signos peritoneales. Laboratorio: GOT 2.640 U/L, GPT 2.860 U/L, GGT 180, FA 412, protrombinemia 52 %, bilirrubina total 9,2 mg/dL (directa 6,6), albúmina 3,4 g/dL. IgM anti-VHA 5,5 U (VN < 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar de forma ambulatoria
D) Solicitar colangiopancreatografía por resonancia magnética
E) Indicar N-acetilcisteína oral

PREGUNTA 53 1.06.1.019

**53.** **Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné consulta por dolor abdominal, malestar y astenia, con ictericia y orinas oscuras. Examen: ictericia, dolor en epigastrio e hipocondrio, hígado palpable 3 cm bajo el reborde costal. Laboratorio: GOT 328 U/L, GPT 459 U/L, bilirrubina 1,8 mg/dL, FA 80, GGT 92, protrombinemia 80 %. Serología: IgG anti-VHA (+), IgM anti-VHA (−), AgHBs (−), anti-HBc totales (+); anti-VHC y autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:**

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

PREGUNTA 54 1.06.1.005

**54.** **Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado hemorragia digestiva. ¿Cuál es la profilaxis indicada?**

A) Ligadura endoscópica de várices + propranolol
B) Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca
C) Instalación electiva de TIPS
D) Terlipresina endovenosa mensual
E) Ácido tranexámico oral permanente

## BLOQUE 4 VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

PREGUNTA 55 1.06.1.003

**55.** **Una paciente de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras, de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico, se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran SGOT: 60 UI/L, SGPT: 56 UI/L, GGT: 570 UI/L, FA: 755 UI/L, bilirrubina total: 21 mg/dl, bilirrubina directa: 19 UI/L. El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer de la cabeza de páncreas
B) Cáncer de vesícula
C) Colangiocarcinoma
D) Hepatocarcinoma
E) Cáncer de la ampolla de Vater

PREGUNTA 56 1.06.1.003

**56.** **Una paciente de 82 años con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por ictericia y coluria, asociado a decaimiento. Niega dolor, pero refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Sus signos vitales son normales y se observa en buen estado general, orientada e hidratada, con ictericia de piel y escleras. Al examen abdominal no se palpan masas ni signos peritoneales. Los exámenes de laboratorio revelan fosfatasas alcalinas: 422 UI/L, GGT: 322 UI/L, GOT: 110 UI/L, GPT: 75 UI/L, protrombinemia: 90% y albúmina sérica: 3,1 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de páncreas
B) Coledocolitiasis residual
C) Cáncer de duodeno
D) Cáncer de la vía biliar
E) Colangitis esclerosante primaria

PREGUNTA 57 1.06.1.003

**57.** **Una paciente de 35 años, presenta dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a meteorismo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en el fondo vesicular, de 4 mm de diámetro, homogéneo y se observa la vía biliar de 5 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:**

A) Control ecográfico en 6 meses
B) Solicitar una TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar una resonancia magnética nuclear abdominal
D) Realizar biopsia del pólipo
E) Realizar colecistectomía laparoscópica

PREGUNTA 58 1.06.1.006

**58.** **Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico más probable es:**

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colangiocarcinoma
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis

PREGUNTA 59 1.06.1.006

**59.** **Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?**

A) Ecografía abdominal
B) Radiografía de abdomen
C) Amilasa / Lipasa
D) Colangioresonancia
E) TAC de abdomen

PREGUNTA 60 1.06.1.006

**60.** **Embarazada de 32 semanas con sx de cole. Eco pared engrosada con calculos y VB 9 o 10 cm. Conducta:**

A) Analgesia hasta fin del embarazo
B) CPRE (PORQ ESTA NO PODRIA SER???)- SGY Porque no tenía clínica de colangitis, que sería la indicación de drenaje inmediato. Sino sólo sospecha de coledocolitiasis.
C) colecistectomía+CIO
D) colecistostomía
E) Colangioresonancia

PREGUNTA 61 1.06.1.006

**61.** **Mujer de 45 años operada de colecistectomía hace 6 meses. Ahora con dolor cólico en hipocondrio derecho, ictericia leve y coledocolitiasis residual confirmada por ecografía. ¿Cuál es el manejo?**

A) CPRE con esfinterotomía y extracción del cálculo
B) Reoperación para exploración de vía biliar
C) Tratamiento médico con ácido ursodesoxicólico
D) Observar y controlar en 3 meses
E) Litotricia extracorpórea

PREGUNTA 62 1.06.1.006

**62.** **Un paciente de 55 años consulta por dolor abdominal, de 3 días de evolución, mayor en el epigastrio, asociado a vómitos alimentarios. Su examen abdominal muestra dolor a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos en la vesícula, de pequeño tamaño. Se solicitan pruebas hepáticas con fosfatasas alcalinas: 520 UI/L, GGT: 612 UI/L, GOT: 102 UI/L y GPT: 87 UI/L, bilirrubinemia: 6,0 mg/dl, con fracción directa de 4,6 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Realizar colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
B) Indicar colangioresonancia
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D) Resolver quirúrgicamente
E) Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso

PREGUNTA 63 1.06.1.006

**63.** **Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 se- manas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un pa- trón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Coledocolitiasis
B) Colestasia farmacológica
C) Síndrome de Mirizzi
D) Esteatosis hepática
E) Colelitiasis

PREGUNTA 64 1.06.1.010

**64.** **Puérpera de 5 días con deposiciones líquidas múltiples con moco y sangre, calambres abdominales y fiebre 38.5°C. Hospitalizada durante el parto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Infección por Clostridioides difficile
B) Gastroenteritis viral
C) Colitis ulcerosa de novo
D) Salmonelosis
E) Síndrome de intestino irritable postinfeccioso

PREGUNTA 65 1.06.1.025

**65.** **Hombre de 55 años, alcohólico crónico y fumador, con dolor epigástrico que se irradia a la espalda, aparece con la ingesta de alimentos y se calma al inclinarse hacia adelante. Presenta baja de peso de 8 kg. Transaminasas y amilasa levemente elevadas. Radiografía: calcificaciones en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Úlcera gástrica perforada
B) Obstrucción intestinal
C) Pancreatitis crónica
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis alcohólica

PREGUNTA 66 1.06.2.003

**66.** **Una paciente de 52 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso, de localización epigástrica e irradiado a los flancos, que se asocia a vómitos y orinas oscuras. Además, ha presentado fiebre hasta 39°C y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de escleras, piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 110x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
C) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

PREGUNTA 67 1.06.2.004

**67.** **[URGENCIA: Colecistitis aguda · 1.06.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Colecistitis aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 68 1.06.2.010

**68.** **Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión ali- mentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e icteri- cia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardiaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:**

A) Isquemia mesentérica
B) Colangitis
C) Pancreatitis
D) Colecistitis
E) Coledcolitiasis

PREGUNTA 69 1.06.1.006

**69.** **Hombre de 62 años consulta por dolor en el hipocondrio derecho, ictericia progresiva, fiebre de 39 °C con calofríos y, en las últimas horas, tendencia a la somnolencia y presión arterial de 90/50 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?**

A) Colecistitis aguda; colecistectomía laparoscópica de urgencia
B) Colangitis aguda grave; reposición de volumen, antibióticos y CPRE urgente para drenaje
C) Coledocolitiasis; colangiorresonancia y luego CPRE electiva
D) Hepatitis aguda; manejo de soporte
E) Absceso hepático; antibióticos y drenaje percutáneo

PREGUNTA 70 1.06.1.006

**70.** **Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta una colelitiasis (múltiples cálculos, vesícula de pared normal). ¿Cuál es la conducta?**

A) Observación; operar solo si aparecen síntomas
B) Ácido ursodesoxicólico para disolver los cálculos
C) Colecistectomía laparoscópica electiva
D) Dieta baja en grasas y control ecográfico anual
E) Colecistectomía solo si los cálculos superan los 2 cm

PREGUNTA 71 1.06.2.010

**71.** **Hombre de 45 años consulta por dolor epigástrico intenso y vómitos biliosos. Al examen: FC 90/min, PA 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando y doloroso a la palpación epigástrica. Exámenes: escleras ictéricas leves, lipasa 190 U/L (VN < 60), bilirrubina total 3,1 mg/dL directa, ecografía con colédoco de 9 mm y microlitiasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Coledocolitiasis
D) Colecistitis aguda
E) Cólico biliar simple

PREGUNTA 72 1.06.2.010

**72.** **Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**

A) CPRE de urgencia en las próximas 24 horas
B) Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio
C) Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas
D) Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva
E) Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

## BLOQUE 5 ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

PREGUNTA 73 1.06.1.009

**73.** **Una paciente de 27 años presenta constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas, duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido en toda su extensión. ¿Cuál es el el tratamiento más adecuado?**

A) Laxantes osmóticos
B) Laxantes de contacto
C) Cambios de hábitos
D) Proquinéticos
E) Cirugía

PREGUNTA 74 1.06.1.014

**74. Mujer de 74 años con epigastralgia de 3 semanas de evolución, sin irradiación, sin baja de peso. Antecedente de dispepsia tratada hace 10 años. AINES ocasionales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Endoscopía digestiva alta (EDA) para descartar lesión orgánica (criterios de alarma por edad >60 años)
B) Iniciar IBP y controlar en 4 semanas
C) Test de Helicobacter pylori no invasivo y tratar si positivo
D) Radiografía de abdomen
E) Ecografía abdominal

PREGUNTA 75 1.06.2.001

**75. Un paciente presenta diarrea abundante, asociada a malestar general. En su tercer día de evolución, presenta dolor abdominal y distensión abdominal progresiva. Al examen Fsico se observa decaído, en malas condiciones generales, subfebril (37,6 °C), con abdomen distendido y doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. Sus signos vitales muestran presión arterial 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca 110 lpm. Se solicita radiograFa de abdomen, que revela dilatación de las asas del colon, alcanzando un diámetro de hasta 10 cm a la altura del ciego. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Síndrome de Hirschsprung
B) Síndrome de Ogilvie
C) Obstrucción intes2nal
D) Coli2s isquémica
E) Megacolon tóxico

PREGUNTA 76 1.06.2.007

**76. Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopía, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopía digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
D) Colonoscopía
E) Angiografía mesentérica

PREGUNTA 77 1.06.2.001

**77. Mujer de 24 años consulta por dolor que comenzó alrededor del ombligo y en 12 horas se localizó en la fosa ilíaca derecha, con náuseas y falta de apetito. Al examen tiene Blumberg positivo en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la primera conducta?**

A) Apendicectomía laparoscópica inmediata
B) Test de embarazo y evaluación ginecológica
C) TAC de abdomen y pelvis con contraste
D) Iniciar antibióticos empíricos y observar 24 horas
E) Colonoscopía urgente

PREGUNTA 78 1.06.2.001

**78. Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de peritonitis fecal difusa. Está febril, taquicárdica e hipotensa. ¿Cuál es la conducta?**

A) Antibióticos endovenosos y reevaluar en 48 horas
B) Drenaje percutáneo guiado por TAC
C) Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
D) Colonoscopía para localizar la perforación
E) Resección sigmoidea laparoscópica con anastomosis primaria diferida

PREGUNTA 79 1.06.2.001

**79. Hombre de 70 años con antecedente de ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva, presenta dolor cólico en el flanco izquierdo y elimina deposiciones con sangre roja. El abdomen está sensible en el flanco izquierdo, sin peritonismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Embolia de la arteria mesentérica superior
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Diverticulitis aguda
E) Enfermedad de Crohn

PREGUNTA 80 1.06.2.001

**80. Paciente de 72 años con fibrilación auricular presenta dolor abdominal súbito y muy intenso. El examen abdominal es prácticamente normal, sin defensa ni Blumberg. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?**

A) TAC de abdomen sin contraste
B) Ecografía abdominal
C) Angio-TAC (o angiografía) mesentérica
D) Radiografía de abdomen simple
E) Colonoscopía urgente

PREGUNTA 81 1.06.2.007

**81. Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta, ¿cuál de los siguientes parámetros determina mejor la gravedad del cuadro?**

A) El hematocrito
B) La hemoglobina
C) La frecuencia cardíaca y la presión arterial
D) El volumen estimado de la hematemesis
E) El recuento de plaquetas

PREGUNTA 82 1.06.2.007

**82. Paciente de 68 años con hemorragia digestiva baja masiva e inestabilidad hemodinámica. Se realiza una colonoscopía urgente que, por la abundante sangre, no logra identificar el sitio del sangrado. ¿Cuál es el siguiente paso?**

A) Repetir la colonoscopía tras una nueva preparación
B) Endoscopía digestiva alta
C) TAC de abdomen sin contraste
D) Laparotomía exploradora inmediata
E) Alta con control ambulatorio en 48 horas

PREGUNTA 83 1.06.2.002

**83.** **Hombre de 45 años consulta por sensación de cuerpo extraño retroesternal tras comer un trozo grande de carne hace 6 horas. Tiene dolor retroesternal y no consigue tragar ni siquiera su saliva. ¿Cuál es la conducta?**

A) Observación por 24 horas
B) Radiografía de tórax y control en 12 horas
C) Endoscopía digestiva alta para desimpactar
D) Bebida carbonatada y enzimas proteolíticas para disolver la carne
E) TAC de tórax con contraste

PREGUNTA 84 1.06.2.002

**84.** **Niño de 5 años se tragó una moneda hace 3 horas. Está asintomático, sin sialorrea ni dificultad para tragar. La radiografía muestra la moneda en la cámara gástrica. ¿Cuál es la conducta más apropiada?**

A) Endoscopía digestiva alta urgente
B) Laparotomía para extraer la moneda
C) Observación con control radiológico cada 1–2 semanas
D) Administrar un laxante para acelerar el tránsito
E) Maniobra de Heimlich

PREGUNTA 85 1.06.2.005

**85.** **Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor abdominal tipo cólico. Dos hermanos tienen síntomas similares. Crece en un percentil bajo pero estable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A) Diarrea crónica inespecífica; suspender los jugos
B) Enfermedad celíaca; dieta sin gluten
C) Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)
D) Fibrosis quística; enzimas pancreáticas
E) Alergia a la proteína de leche de vaca; fórmula hidrolizada

PREGUNTA 86 1.06.2.005

**86.** **Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica con estrías de sangre, reflujo y episodios de exantema y sibilancias. El incremento ponderal está enlentecido. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más apropiado?**

A) Test del sudor
B) Anticuerpos anti-transglutaminasa
C) Prueba terapéutica con fórmula extensamente hidrolizada por 2–4 semanas y posterior reintroducción
D) Parasitológico seriado de deposiciones
E) Endoscopía digestiva alta con biopsias

PREGUNTA 87 1.06.1.027

**87.** **Recién nacido de 4 semanas, previamente sano, con 5 días de vómitos explosivos posprandiales. Se muestra ávido por alimentarse. Al examen tiene signos de deshidratación; en el laboratorio destaca hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?**

A) pH-metría esofágica de 24 horas
B) Radiografía de abdomen simple
C) Ecografía abdominal
D) Endoscopía digestiva alta
E) TAC de abdomen

PREGUNTA 88 1.06.1.027

**88.** **Niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y manchado fecal en la ropa interior. Al examen se palpa una masa en el hipogastrio y, al tacto rectal, una gran masa fecal dura en la ampolla rectal. ¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Dieta rica en fibra y aumento de la ingesta de agua
B) Polietilenglicol por vía oral para desimpactar
C) Extracción digital del fecaloma bajo sedación
D) Laxantes osmóticos en dosis de mantenimiento de forma indefinida
E) Derivación quirúrgica

PREGUNTA 89 1.01.1.001

**89.** **Recién nacido prematuro de 30 semanas, a los 6 días de vida, presenta residuo gástrico bilioso, distensión abdominal y deposiciones con sangre. La radiografía de abdomen muestra aire en el espesor de la pared intestinal. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Atresia duodenal
B) Invaginación intestinal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Enfermedad de Hirschsprung
E) Vólvulo del intestino medio

PREGUNTA 90 1.01.1.001

**90.** **Niño de 3 años, sano, consulta por un episodio de deposición con abundante sangre roja oscura, sin dolor abdominal. Está pálido y taquicárdico; el abdomen es blando, sin masas. La colonoscopía no muestra lesiones. ¿Cuál es el examen diagnóstico más apropiado?**

A) Repetir la colonoscopía con mejor preparación
B) Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio-99m
C) Ecografía abdominal
D) Radiografía de abdomen simple
E) TAC de abdomen con contraste

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ESÓFAGO Y ESTÓMAGO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 1** **Respuesta: A** Cáncer de páncreas `1.06.1.002` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta algo difícil. Tiene una ictericia obstructiva, con un patrón colestásico, lo que hace sospechar un cáncer que obstruye la vía biliar. La dilatación de la vesícula (signo de Courvoisier-Terrier) y la dilatación de la vía biliar extrahepática es característica de la obstrucción distal del colédoco, por lo que lo más probable es que sea un cáncer de cabeza de páncreas. El antecedente de fumar también orienta a esa causa. El diverVculo duodenal es mucho más infrecuente. El colangiocarcinoma generalmente está ubicado más alto en la vía biliar.

**PREGUNTA 2** **Respuesta: A** Cáncer gástrico `1.06.1.004` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece un cáncer gástrico. Siempre lo primero es confirmarlo con EDA y biopsia

**PREGUNTA 3** **Respuesta: C** Diarrea crónica `1.06.1.011` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Lo primero a descartar es el cáncer de colon (después la enfermedad celíaca).

**PREGUNTA 4** **Respuesta: A** Disfagia `1.06.1.013` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la disfagia lógica y por el antecedente de probable RGE (usa omeprazol). La acalasia produce disfagia ilógica. La edad sugiere también cáncer.

**PREGUNTA 5** **Respuesta: E** Enfermedad diverticular complicada `1.06.1.016` Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una diverticulitis aguda post colonoscopía. Se estudia con TAC. Está absolutamente contraindicada la colonoscopía

**PREGUNTA 6** **Respuesta: C** Reflujo gastroesofágico `1.06.1.027` Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene reflujo clínico y por endoscopía. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A** Úlcera péptica `1.06.1.030` Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una úlcera duodenal Activa. Aunque el test de ureasa esté negativo, si no usa AINES, se asume que es por H. pylori, porque el 90% de las úlceras duodenales son por esa causa y el test de ureasa no es un examen tan bueno. Es una pregunta difícil. En el caso de la úlcera gástrica, es más probable que pueda ser por otra causa (solo 70% es por HP) y se tendría que estudiar. También se estudiaría si hubiese algo más que hiciera sospechar otra enfermedad, como un Cröhn o un Zollinger Ellison.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: A** Afagia aguda `1.06.2.002` Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 50). Evalúa el manejo clínico de Afagia aguda según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett**

Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINE: se asume infección por Helicobacter pylori aunque el test de ureasa sea negativo (falso negativo frecuente si hay sangrado reciente o uso previo de IBP/antibióticos), porque el 90 % de las úlceras duodenales son por H. pylori. La conducta es la terapia erradicadora de primera línea (IBP + amoxicilina + claritromicina, 14 días), no solo supresión ácida. B y E tratan la úlcera pero no la causa. D corresponde a manejo de ERGE, no de úlcera. C retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: C**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett**

Falla de la erradicación de primera línea confirmada por test de control positivo: se indica un esquema de segunda línea que evite la claritromicina (terapia cuádruple con bismuto, o levofloxacino + amoxicilina + IBP). Repetir el mismo esquema (A) mantiene la resistencia a claritromicina. La endoscopía (B) sería obligatoria para el control de la úlcera gástrica en sí, pero la pregunta apunta a la conducta frente a la falla de erradicación. D y E no corrigen la infección persistente.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

1.06.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori**

Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test resulte negativo, porque el 90 % son por H. pylori y el test de ureasa tiene falsos negativos frecuentes (uso previo de IBP o antibióticos, sangrado reciente). Dar solo omeprazol (C) cicatriza pero no previene la recidiva. Repetir exámenes (D, E) retrasa el tratamiento sin cambiar la conducta.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: C**

1.06.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori**

Epigastralgia con endoscopía normal y sin signos de alarma es, por definición, dispepsia funcional (diagnóstico de exclusión que requiere endoscopía normal). El manejo es educación, manejo del estrés, moduladores del dolor y una prueba con IBP; se puede ofrecer erradicación de H. pylori si el test fuera positivo, lo que aquí no aplica. No corresponde tratar como úlcera (A) ni repetir estudios invasivos sin nuevas banderas rojas.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: C**

1.06.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Disfagia y Trastornos Motores del Esófago**

Disfagia lógica (progresiva, de sólidos a líquidos) con baja de peso en un fumador es cáncer de esófago mientras no se demuestre lo contrario. El diagnóstico se hace con endoscopía digestiva alta y biopsia; el TAC y la endosonografía vienen después, para etapificar. La manometría y el esofagograma se reservan para la disfagia ilógica (sospecha de trastorno motor).

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: C**

1.06.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Disfagia y Trastornos Motores del Esófago**

Disfagia alta (la comida se queda "en la garganta", a nivel del esfínter esofágico superior) con halitosis marcada y regurgitación de alimento no digerido es el cuadro típico del divertículo de Zenker: el alimento se acumula en el saco diverticular y fermenta. El diagnóstico se confirma con esofagograma con bario. La halitosis es la clave que lo separa de la acalasia.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: C**

1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico**

En la ingesta de cáusticos la primera medida es la endoscopía digestiva alta precoz para graduar el daño de la mucosa y decidir si se observa, se deja en régimen cero con nutrición parenteral o se opera. El lavado gástrico, el carbón activado, los neutralizantes y provocar el vómito están contraindicados porque el daño es inmediato y todas esas maniobras lo agravan (reexposición del esófago al cáustico, perforación).

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico**

Vómitos intensos seguidos de dolor torácico y enfisema subcutáneo (crepitación cervical), con fiebre y taquicardia, configuran la tríada del síndrome de Boerhaave (perforación esofágica espontánea). El Mallory-Weiss también sigue a los vómitos, pero se manifiesta con hematemesis y no produce enfisema ni sepsis. El examen inicial es la radiografía de tórax buscando neumomediastino; la endoscopía está contraindicada.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: B**

1.06.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico**

Baja de peso con epigastralgia en un mayor de 40 años obliga a descartar cáncer gástrico, y el examen que confirma es la endoscopía digestiva alta con biopsias (además detecta la úlcera y permite tomar muestras para H. pylori). El TAC se usa después, para etapificar. Si el paciente además tuviera ictericia, la sospecha cambiaría a cáncer de páncreas y ahí sí el examen inicial sería el TAC.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

1.06.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico**

El factor pronóstico principal del cáncer gástrico es la profundidad de invasión de la pared. Este es un cáncer incipiente (limitado a la mucosa), el de mejor pronóstico, y con esos criterios (lesión pequeña, bien diferenciada, sin úlcera, sin invasión submucosa) puede tratarse con resección endoscópica de la mucosa; en otros casos, gastrectomía. Observar (A) o solo erradicar H. pylori (C) deja el tumor sin tratar.

---

## BLOQUE 2 INTESTINO Y COLON · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A**

1.06.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Trastornos digestivos funcionales**

El síndrome de intestino irritable SII) se caracteriza por dolor abdominal, que suele disminuir con la evacuación y cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. No Gene signos de alarma que hagan pensar en patología orgánica. Aunque su consGpación es funcional, el diagnóstico “consGpación funcional” se uGliza en caso en que no Gene dolor abdominal y, por tanto, no cumple con los criterios de SII.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A** **Diarrea en inmunosuprimidos** 1.06.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diarrea en inmunosuprimidos" (1.06.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: B** **Enfermedad celiaca** 1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una enfermedad celíaca clásica del adulto (diarrea y ferropenia).

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

1.06.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Enfermedad diverticular no complicada**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad diverticular no complicada" (1.06.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: C** **Enfermedad inflamatoria intestinal** `1.06.1.018` `Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Enfermedad de Crohn: compromiso transmural + patrón en empedrado + úlceras aftosas con mucosa intercalada normal + fístula perianal + úlceras orales + localización que puede ser cualquier tramo del tubo digestivo. La CU no tiene fístulas ni compromiso ileal típico ni úlceras orales.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: A** **Intolerancia a la lactosa** `1.06.1.023` `Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo`

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Intolerancia a la lactosa" (1.06.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A** **Parasitosis intestinales** `1.06.1.026` `Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo`

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Parasitosis intestinales" (1.06.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B** **Síndrome de malabsorción** `1.06.1.028` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Pregunta discuGble. Tiene un síndrome de malabsorción intestinal, el que Gene muchas causas, sin que sea posible diferenciarlas con la sola clínica. Sin embargo, la presencia de esteatorrea franca y de empeoramiento de la clínica con la ingesta de grasas es lo clásico de la deficiencia de enzimas pancreáticas. La enfermedad celíaca es más frecuente y puede tener esteatorrea, pero suele ser más suGl, predominando la anemia, otros déficits nutricionales y molestias digestivas inespecíficas.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: D** **Tumores de colon** `1.06.1.029` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Es un cuadro sugerente de cáncer de colon (constipación y anemia en adulto mayor), que se estudia con colonoscopía.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B** **Diarrea aguda** `1.06.2.005` `Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo`

En mi opinión es una simple diarrea aguda.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

**Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable** `1.06.1.008` `Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo` `GES`

Tiene múltiples signos de alarma: edad > 50 (límite), baja de peso involuntaria, cambio reciente del hábito intestinal, rectorragia y antecedente familiar de cáncer de colon. Eso descarta el manejo como trastorno funcional (A, C, E) y obliga a colonoscopía para descartar cáncer colorrectal. El test de sangre oculta (D) es una herramienta de tamizaje poblacional en personas asintomáticas, no sirve para estudiar a un paciente sintomático con banderas rojas.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

**Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable** `1.06.1.008` `Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo` `GES`

Cumple criterios de Roma IV (dolor recurrente que alivia con la defecación y se asocia a cambio en la consistencia de las deposiciones) sin ningún signo de alarma y con exámenes básicos normales, incluyendo serología celíaca negativa. El diagnóstico de SII es clínico y positivo; corresponde iniciar tratamiento (educación, dieta, fármacos según síntoma) sin más estudios. Las alternativas A, C y D son estudios invasivos innecesarios en ausencia de banderas rojas.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación**

Diarrea que aparece hasta un mes después del uso de antibióticos obliga a descartar Clostridioides difficile. El examen de elección actual es la PCR de toxina en deposiciones, más sensible que la detección de toxinas A y B. El tratamiento es metronidazol oral y, si falla, vancomicina oral; la respuesta se evalúa por la clínica, no repitiendo la PCR (puede quedar positiva por semanas).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: D**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación**

La diarrea aguda del niño, por regla general, no lleva antibiótico. Solo se indica ante disentería con mal estado general, fiebre alta persistente por varios días, dolor abdominal intenso o aislamiento de Shigella o E. coli enteroinvasora. Este niño está en buen estado, sin disentería y con fiebre de pocas horas: el manejo es hidratación y observación.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa**

La causa más frecuente de falta de respuesta en la celíaca es la transgresión dietética, pero en ese caso los anticuerpos suelen mantenerse elevados. Aquí los anticuerpos están negativos (lo que confirma buena adherencia) y aun así persiste la malabsorción: eso obliga a descartar un linfoma T asociado a enteropatía, complicación grave de la enfermedad celíaca que requiere imágenes y biopsias repetidas.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: C**

1.06.1.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa**

Ictericia, daño hepático, cataratas y retraso del desarrollo en el recién nacido configuran una galactosemia. El tratamiento es eliminar toda la galactosa: están contraindicadas la lactancia materna y las fórmulas de origen animal. La fórmula sin lactosa no sirve, porque aporta galactosa (la lactasa añadida hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa). Se usa fórmula de soya u otra de origen vegetal.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

1.06.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn**

La colonoscopía define el caso: inflamación en parches (zonas de mucosa indemne) y respeto del recto. Cualquiera de esas dos características, por sí sola, descarta la colitis ulcerosa —que es continua y siempre rectal— y establece el diagnóstico de enfermedad de Crohn.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: D**

1.06.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn**

La colitis ulcerosa de larga data multiplica el riesgo de cáncer colorrectal, sobre todo rectal, y todo sangrado digestivo bajo nuevo en un adulto exige colonoscopía completa: la rectosigmoidoscopía no explora el colon proximal y dejaría lesiones sin ver. No se asume un brote ni se inician corticoides antes de descartar neoplasia.

---

## BLOQUE 3 HÍGADO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: E** **Ascitis**

1.06.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una carcinomatosis tanto por la clínica de cáncer (fumador, baja de peso, cuadro progresivo) como por el análisis con un exudado mononuclear y ADA baja (se interpreta similar al estudio de líquido pleural). No es una PBE (peritoniGs bacteriana espontánea), ya que requiere más de 250 PMN y predominio PMN.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: B** **Colestasia** 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una CBP (cirrosis biliar primaria) clásica: mujer de edad media, con colestasia crónica, con elevación prominente de las fosfatasas alcalinas; aunque falta la clínica de astenia, que es el síntoma más frecuente. No tiene factores de riesgo para la esteatosis hepática (hígado graso) y, además, suele cursar con hepatitis y no colestasia. La colestasia por compresión externa, suele ser por cáncer y viene con mucha ictericia (no es el caso). La colangitis esclerosante primaria puede tener un cuadro similar, pero en lugar de ser una mujer de edad media, suele ser en hombres, con antecedente de colitis ulcerosa.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A**

**Hepatitis aguda A no complicada** 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Cuadro clásico

**PREGUNTA 40** **Respuesta: D**

**Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas** 1.06.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una hepatitis, que, por descarte, es farmacológica (por la isotretinoína). No es VHA, porque la IgM está negativa. No es VHB porque el antígeno de superficie está negativo (no aporta mayor información los anticuerpos totales anticore). No es VHC, porque los anticuerpos totales anti VHC está negativos.

**PREGUNTA 41** **Respuesta: E** **Hepatitis crónica** 1.06.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una hepatitis crónica. El antecedente de transfusión orienta a hepatitis C, pero la verdad es que debe estudiarse con más exámenes, como por ejemplo el Ag VHBs, por lo que es una mala pregunta. Antes del año 2000, los casos de hepatitis B eran casi cero, por lo que no puede ser.

**PREGUNTA 42** **Respuesta: A** **Insuficiencia hepática crónica** 1.06.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia hepática crónica" (1.06.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B** **Masa hepática** 1.06.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un adenoma hepático, por el aspecto, el tamaño (sólido, hipoecogénico, aspecto homogéneo) y por la alfafetoproteína no elevada. La cirrosis aumenta el riesgo de adenomas y hepatocarcinomas. Metástasis: se ven hipoecogénicas, sólidas y múltiples. Hepatocarcinoma: se ve heterogéneo y más grande, sólido y además eleva la AFP. Quiste: se ve anecogénico, con refuerzo posterior. Hemangioma: se ve hiperecogénico, homogéneo.

**PREGUNTA 44** **Respuesta: E** **Encefalopatía hepática** 1.06.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La encefalopatía hepática se trata con lactulosa. Sin embargo lo más importante siempre es descartar patología descompensante (infecciones). El amonio sirve para hacer el diagnóstico: se eleva la amonemia en la encefalopatía hepática

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B** **Hepatitis aguda A complicada** 1.06.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hepatitis aguda grave: El cuadro clínico es compatible con una hepatitis aguda, confirmada por las pruebas hepáticas que muestran una elevación significativa de las transaminasas. La IgM positiva para el virus de la hepatitis A confirma la etiología. La gravedad del cuadro radica en la disminución de la protrombinemia, lo que requiere manejo hospitalario. Aunque aún no cumple con los criterios de hepatitis fulminante (no hay compromiso de la conciencia), la caída de la protrombinemia aumenta el riesgo de evolucionar hacia ella.

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A** **Insuficiencia hepática aguda** 1.06.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia hepática aguda" como urgencia clínica (1.06.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: D**

**Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico** 1.06.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Es una PBE. También hay que dar albúmina (1,5 g/Kg de peso el primer día y 1,0 g/Kg de peso al tercer día), pero los ATB son lo más importante. Se da Cefotaximo.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A** **Síndrome hepatorrenal** 1.06.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome hepatorrenal" como urgencia clínica (1.06.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

**Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico** 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hiperbilirrubinemia indirecta aislada, con el resto de las pruebas hepáticas y el hemograma normales, en un joven asintomático: es un síndrome de Gilbert, un trastorno hereditario benigno de la conjugación de la bilirrubina que afecta al 5–10 % de la población y suele hacerse evidente con el ayuno o las infecciones. No requiere estudio adicional ni tratamiento.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

**Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico** 1.06.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El patrón es colestásico con dolor y sin fiebre: coledocolitiasis. La ecografía muestra la vía biliar dilatada pero no ve el cálculo, así que el siguiente paso es la colangiorresonancia para confirmarlo antes de someter a la paciente a una CPRE (que es invasiva y tiene riesgo de pancreatitis). Se va directo a CPRE solo si hay colangitis o si la ecografía ya vio el cálculo en el colédoco.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Hepatitis Aguda y Crónica** 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El AgHBs negativo descarta infección activa y los anti-HBs positivos indican inmunidad. Como no se informan anti-HBc, el patrón "anti-HBs aislado" corresponde a inmunidad por vacuna (una infección resuelta también tendría anti-HBc IgG positivos). En ningún caso hay enfermedad activa ni período de ventana.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

**Hepatitis Aguda y Crónica** 1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una hepatitis A aguda (IgM anti-VHA positiva) con transaminasas muy elevadas y, sobre todo, protrombinemia de 52 %. Aún no hay encefalopatía, por lo que no cumple criterios de hepatitis fulminante, pero la caída del tiempo de protrombina es el marcador de gravedad y de riesgo de progresión: obliga a hospitalizar para vigilancia. El manejo ambulatorio se reserva para la hepatitis A no complicada con protrombina normal.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: D**

**Hepatitis Aguda y Crónica**

1.06.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La IgM anti-VHA negativa descarta hepatitis A aguda (la IgG solo marca contacto previo). El AgHBs negativo descarta infección B activa; los anti-HBc totales positivos sin AgHBs indican solo exposición pasada. Por descarte, y por la relación temporal con un fármaco hepatotóxico conocido (isotretinoína), el diagnóstico es hepatitis por fármacos: la conducta es suspender el fármaco de inmediato.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: B**

**Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal**

1.06.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La profilaxis primaria de la hemorragia variceal (paciente que nunca ha sangrado) es el betabloqueo no selectivo, titulado para reducir la frecuencia cardíaca. La ligadura endoscópica se añade en la profilaxis secundaria (tras un primer sangrado) o se usa sola cuando el betabloqueo está contraindicado (asma, EPOC grave, intolerancia).

## BLOQUE 4 VÍA BILIAR Y PÁNCREAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: B** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Las pruebas hepáticas muestras una colestasia clara y la clínica también. La colestasia silente (sin dolor) o con escaso dolor suele ser por cáncer (cualquier a de los de las opciones). De todos modos, orienta a cáncer de vesícula el hecho de que sea mujer y, además, el antecedente de cólicos biliares (ya que la colelitiasis es el factor de riesgo más importante). El cáncer de cabeza de páncreas suele preguntarse en diabéticos o fumadores y suele mostrarse la dilatación del colédoco en la ecografía.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: D** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sospecha de Cáncer de Vía Biliar: La sospecha clínica en este paciente es de un cáncer que obstruye la vía biliar, considerando su edad y la presencia de ictericia sin dolor. El antecedente de colecistectomía previa hace poco probable un cáncer de vesícula biliar, pero aún puede tener uno de vía biliar o colangiocarcinoma.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A** **Cáncer de vesícula y vías biliares** 1.06.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene clínica de un trastorno digestivo funcional (ej. Síndrome de intestino irritable) y los hallazgos en la ecografía no muestran sino un pólipo de características benignas (son malignos y hay que sacarlos si: miden más de 1 cm, tienen cálculos asociados, tienes aspecto invasor o heterogéneo). La vía biliar normal es hasta 7 mm.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Probablemente tiene una colelitiasis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la colelitiasis.

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Colelitiasis.

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Coledocolitiasis residual sintomática: primera línea = CPRE con esfinterotomía endoscópica y extracción del cálculo. Evita reoperación y tiene alta tasa de éxito (>90%).

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una coledocolitiasis. Se debe estudiar inicialmente con una colangioresonancia y luego (si la colangioRMN ve los cálculos), se procede a la CPRE (también se hace la CPRE si tiene clínica de colangitis o si la eco ve los cálculos en el colédoco).

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A** **Colelitiasis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una colédocolitiasis. Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A** **Diarrea asociada a antibióticos** 1.06.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Diarrea con sangre + fiebre en paciente hospitalizada reciente + puérpera (exposición a antibióticos perinatales) = infección por C. difficile. Diagnóstico: toxina A/B en deposiciones. Tratamiento: vancomicina oral.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: C** **Pancreatitis crónica** 1.06.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pancreatitis crónica: dolor epigástrico irradiado a la espalda + ingesta de alcohol crónico + posición antiálgica en flexión + baja de peso + CALCIFICACIONES pancreáticas en radiografía = tríada diagnóstica. El dolor mejora en reposo y empeora con la ingesta.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: E** **Colangitis** 1.06.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una colangitis aguda clásica. Se trata con drenaje endoscópico de la vía biliar (además, se da SF ev, ATB ev y, en segunda instancia, se realiza una colecistectomía laparoscópica).

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A** **Colecistitis aguda** 1.06.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Colecistitis aguda" como urgencia clínica (1.06.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: C** **Pancreatitis aguda** 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pancreatitis clásica. SEGUNDA PARTE

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

**Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dolor + ictericia + fiebre (tríada de Charcot) con hipotensión y compromiso de conciencia constituyen la péntada de Reynolds: una colangitis aguda grave. La prioridad es la reanimación con volumen, los antibióticos de amplio espectro y, sobre todo, el drenaje biliar urgente mediante CPRE. La colecistectomía se difiere hasta que el paciente se estabilice.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: C**

**Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis** 1.06.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, que tiene la incidencia de cáncer de vesícula más alta del mundo, la conducta ante una colelitiasis —aunque sea asintomática— es la colecistectomía laparoscópica electiva. El GES garantiza esta cirugía preventiva en el grupo de 35 a 49 años. La disolución con ursodesoxicólico y la observación no protegen del cáncer.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B** Pancreatitis Aguda 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La lipasa está sobre 3 veces el límite superior (> 180 U/L) junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda, y aunque coexista una coledocolitiasis (colédoco dilatado, patrón colestásico), "manda" la pancreatitis por ser la condición más grave y la que define la conducta. No hay fiebre ni compromiso hemodinámico que hagan pensar en colangitis (A). El colédoco dilatado y la ictericia descartan un cólico biliar simple (E) y la colecistitis (D) cursaría con Murphy y sin esta magnitud de ictericia.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B** Pancreatitis Aguda 1.06.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En la pancreatitis biliar leve que ya resolvió, la colecistectomía laparoscópica debe realizarse en el mismo ingreso, porque diferirla se asocia a alta tasa de recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis en las semanas siguientes. La CPRE urgente (A) solo se indica si hay colangitis u obstrucción biliar persistente, lo que aquí no ocurre (afebril, vía biliar normal). La colangiorresonancia (D) no aporta porque la probabilidad de coledocolitiasis es baja. Diferir la cirugía (C) o no operar (E) deja al paciente expuesto a un nuevo evento.

---

## BLOQUE 5 ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C** Constipación 1.06.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

El dolicolon (colon largo) no ha demostrado asociarse efectivamente a constipación. La conducta es tratar la constipación en un paciente joven, es decir, mejorar los hábitos. También es aconsejable aumentar la fibra en la dieta. Los laxantes se desaconsejan, ya que producen dependencia y solo se usan en problemas transitorios o cuando fallan las medidas generales.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** Dispepsia 1.06.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Dispepsia en >60 años = criterio de alarma por edad → EDA obligatoria para descartar cáncer gástrico, úlcera péptica u otras lesiones orgánicas. No se puede tratar empíricamente en este grupo etario.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: E** Abdomen agudo 1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un megacolon tóxico. El diagnóstico se confirma por la tríada de: 1) antecedente de coliGs (diarrea), 2) dilatación colónica >6 cm en radiografía y 3) signos de toxicidad sistémica (hipotensión, taquicardia y fiebre). Es una emergencia médica que requiere descompresión y soporte hemodinámico agresivo.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: D** Hemorragia digestiva alta y baja 1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La colonoscopía es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopía normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis**

1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En toda mujer en edad fértil con dolor en la fosa ilíaca derecha y sospecha de apendicitis, lo primero es descartar patología ginecológica y, sobre todo, un embarazo ectópico: se solicita test de embarazo y evaluación ginecológica (con ecografía). Recién después se confirma la apendicitis (clínica + ecografía) y se lleva a pabellón. Operar sin este paso puede pasar por alto un ectópico roto.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: C**

**Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis**

1.06.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Aire y líquido libre con peritonitis fecal corresponde a un Hinchey IV (perforación libre con contaminación fecal), que junto con el Hinchey III (peritonitis purulenta) es indicación de cirugía de urgencia: resección del sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal (operación de Hartmann), reconstruyendo el tránsito meses después. El manejo médico o percutáneo solo sirve en los abscesos (Hinchey I–II).

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: C**

**Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular**

1.06.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dolor en el hemiabdomen izquierdo con hematoquecia en un adulto mayor con ateroesclerosis, precipitado por un episodio de hipotensión (bajo flujo), es característico de la colitis isquémica, que afecta las zonas frontera de irrigación del colon (ángulo esplénico, rectosigmoides). Suele ser transitoria y responde al manejo médico. La embolia mesentérica da dolor mucho más intenso y difuso, con disociación clínica, en el contexto de fibrilación auricular.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: C**

**Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular**

1.06.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La sospecha es una embolia mesentérica (fibrilación auricular + dolor súbito intenso + disociación clínica). El examen de elección es el angio-TAC, que muestra el defecto de llene en la arteria mesentérica superior; la angiografía formal se usa cuando además se planea un tratamiento endovascular. El TAC sin contraste y la radiografía simple no muestran el émbolo y hacen perder tiempo valioso.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: C**

**Hemorragia Digestiva Alta y Baja**

1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En el sangrado agudo se pierde sangre completa (plasma y glóbulos rojos en proporción), por lo que el hematocrito inicial suele ser normal y solo cae horas después, cuando el líquido intersticial diluye la masa eritrocitaria. La gravedad al momento de la presentación la marca el compromiso hemodinámico: taquicardia (lo más precoz), ortostatismo y, finalmente, hipotensión. Nunca se debe esperar el hematocrito para iniciar la reanimación.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

**Hemorragia Digestiva Alta y Baja**

1.06.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cerca del 10 % de las hemorragias que se manifiestan como hematoquecia tienen en realidad un origen alto (HDA masiva con tránsito acelerado). Por eso, si la colonoscopía urgente no localiza el sangrado en un paciente inestable, el siguiente paso es la endoscopía digestiva alta. Si tampoco la localiza, se continúa con angio-TAC/angiografía (que puede ser terapéutica) y, en último término, cirugía.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: C** **Cuerpo Extraño Digestivo** 1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La comida impactada en el esófago con dolor e incapacidad de tragar la saliva (obstrucción esofágica completa) requiere endoscopía digestiva alta para retirarla, sin demora, por el riesgo de aspiración y de perforación. Solo se puede observar hasta 24 horas cuando el paciente está sin dolor y tolera líquidos. Tras resolver el episodio conviene estudiar el esófago (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo de Schatzki).

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: C** **Cuerpo Extraño Digestivo** 1.06.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Una moneda (objeto romo, no cáustico, no magnético) que ya pasó el esófago y está en el estómago, en un niño asintomático, se maneja con observación y control radiológico cada 1–2 semanas: la gran mayoría se elimina espontáneamente sin complicaciones. La endoscopía se reservaría si el objeto no progresa en 3–4 semanas o si aparecen síntomas. Solo las pilas, los imanes múltiples y los objetos afilados o largos se retiran aunque estén en el estómago.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: C**

**Diarrea Aguda y Crónica en el Niño**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Diarrea crónica con flatulencia y dolor cólico en un preescolar de zona rural, con varios convivientes afectados, es muy sugerente de giardiasis. Se confirma con parasitológico seriado (3 muestras en días distintos) y se trata con tinidazol o metronidazol. La giardiasis puede producir un síndrome de malabsorción idéntico al de la celíaca, por lo que siempre debe descartarse antes de ese diagnóstico.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: C**

1.06.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Diarrea Aguda y Crónica en el Niño**

Un lactante con síntomas gastrointestinales (diarrea con sangre, reflujo, mal incremento) y alérgicos (exantema, sibilancias) sugiere alergia a la proteína de leche de vaca. El diagnóstico se hace con prueba terapéutica: se cambia a fórmula extensamente hidrolizada (o de aminoácidos) por 2–4 semanas y, si mejora, se reintroduce la proteína de leche de vaca; la reaparición de los síntomas confirma el diagnóstico. No existe un test sanguíneo validado para esta condición.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: C**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño**

Vómitos explosivos y proyectivos que comienzan entre la 2.ª y la 6.ª semana de vida, en un lactante hambriento, con deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica (por la pérdida de ácido clorhídrico en los vómitos), son característicos de la estenosis hipertrófica del píloro. El diagnóstico se confirma con ecografía abdominal, que muestra el músculo pilórico engrosado. El tratamiento es la corrección hidroelectrolítica seguida de la pilorotomía de Ramstedt.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: B**

1.06.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño**

Antes de cualquier medida de mantenimiento hay que desimpactar el fecaloma, y el tratamiento de elección para la desimpactación es el polietilenglicol por vía oral (alternativa: enema). El manchado fecal es pseudoincontinencia por rebosamiento alrededor del fecaloma. La dieta y los laxantes de mantenimiento (fase 2) recién se inician una vez vaciado el recto; la extracción digital se reserva para casos excepcionales.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: C**

1.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones**

Un recién nacido prematuro con la tríada de retención gástrica, distensión abdominal y hematoquecia, junto con neumatosis intestinal (aire en la pared del intestino) en la radiografía, tiene una enterocolitis necrotizante. El manejo inicial es régimen cero, nutrición parenteral total, sonda para descompresión y antibióticos endovenosos; la cirugía se indica ante neumoperitoneo (perforación) o deterioro pese al tratamiento médico.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: B**

1.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones**

Una hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño, con colonoscopía normal, orienta a un divertículo de Meckel: la mucosa gástrica ectópica que contiene secreta ácido y ulcera el íleon adyacente. El examen de elección es la cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m, que es captado por esa mucosa gástrica ectópica. La colonoscopía no alcanza el íleon donde se ubica el divertículo.

---

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 04 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# RESPIRATORIO

## 90 Preguntas de Práctica

Neumología Clínica

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Respiratorio · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR** | | | | | |
| 1.05.1.002 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.1.003 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.1.005 | Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q17 | Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.1.006 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q13 | Tomo 04 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.05.1.009 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3 | Tomo 04 · C.9 (Pág. 22) |
| 1.05.1.016 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q15 | Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.05.1.017 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16 | Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.05.1.020 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4 | Tomo 04 · C.20 (Pág. 44) |
| 1.05.1.021 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 04 · C.21 (Pág. 46) |
| 1.05.1.035 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q14 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.2.002 | Aspiración de cuerpo extraño con asfixia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.2.003 | Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.2.004 | Crisis Asmática en el Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q8, Q9, Q10 | Tomo 04 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.05.2.006 | Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 04 · 1.5 (Pág. 15) |
| 1.05.4.001 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7 | Tomo 04 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 2: INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES** | | | | | |
| 1.05.1.001 | Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.008 | Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33, Q34 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.022 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19 | Tomo 04 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.05.1.027 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q20, Q21, Q22, Q23, Q24 | Tomo 04 · 2.1 (Pág. 22) |
| 1.05.1.028 | Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 04 · 2.2 (Pág. 26) |
| 1.05.1.029 | Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28) |
| 1.05.1.030 | Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29, Q30 | Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28) |
| 1.05.1.036 | Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.1.037 | Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q36 | Tomo 04 · 2.5 (Pág. 32) |
| **BLOQUE 3: PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS** | | | | | |
| 1.05.1.010 | Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40 | Tomo 04 · 3.1 (Pág. 39) |
| 1.05.1.011 | Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41, Q42, Q43, Q44, Q45 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.05.1.012 | Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q42, Q43, Q44, Q45, Q46 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.05.1.013 | Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 04 · 3.5 (Pág. 51) |
| 1.05.1.031 | Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47, Q48, Q49 | Tomo 04 · 3.3 (Pág. 45) |
| 1.05.1.032 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.2.011 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q51, Q52 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.2.013 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q51, Q53 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.2.014 | Traumatismo torácico simple | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR** | | | | | |
| 1.05.1.004 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.007 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q58, Q59, Q60 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.1.008 | Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.015 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.05.1.018 | Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60) |
| 1.05.1.019 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.1.025 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59, Q60, Q61 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.1.026 | Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60) |
| 1.05.1.034 | Síndromes mediastínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.1.038 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59, Q60, Q62 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.2.005 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68, Q69 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.05.2.007 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q72 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.5.005 | Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57 | Tomo 04 · 4.1 (Pág. 56) |
| **BLOQUE 5: CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO** | | | | | |
| 1.05.1.014 | Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83 | Tomo 04 · 5.2 (Pág. 75) |
| 1.05.1.023 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |
| 1.05.1.024 | Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q87, Q88, Q89 | Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79) |
| 1.05.1.033 | Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84, Q85, Q86 | Tomo 04 · 5.3 (Pág. 77) |
| 1.05.2.001 | Asfixia por inmersión | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 04 · C.23 (Pág. 50) |
| 1.05.2.008 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |
| 1.05.2.009 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78, Q79, Q81 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.2.010 | **Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q88, Q89, Q90 | Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79) |
| 1.05.2.012 | **Paro cardiorespiratorio** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Respiratorio · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.001 | Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.002 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.1.003 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.1.004 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.1.005 | Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q17 | Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.1.006 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q13 | Tomo 04 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.05.1.007 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q58, Q59, Q60 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.1.008 | Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33, Q34, Q56, Q57 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.009 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3 | Tomo 04 · C.9 (Pág. 22) |
| 1.05.1.010 | Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40 | Tomo 04 · 3.1 (Pág. 39) |
| 1.05.1.011 | Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41, Q42, Q43, Q44, Q45 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.05.1.012 | Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q42, Q43, Q44, Q45, Q46 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.05.1.013 | Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 04 · 3.5 (Pág. 51) |
| 1.05.1.014 | Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83 | Tomo 04 · 5.2 (Pág. 75) |
| 1.05.1.015 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.05.1.016 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q15 | Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.05.1.017 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16 | Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.018 | Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60) |
| 1.05.1.019 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.1.020 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4 | Tomo 04 · C.20 (Pág. 44) |
| 1.05.1.021 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 04 · C.21 (Pág. 46) |
| 1.05.1.022 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19 | Tomo 04 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.05.1.023 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |
| 1.05.1.024 | Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q87, Q88, Q89 | Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79) |
| 1.05.1.025 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59, Q60, Q61 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.1.026 | Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60) |
| 1.05.1.027 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q20, Q21, Q22, Q23, Q24 | Tomo 04 · 2.1 (Pág. 22) |
| 1.05.1.028 | Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q25, Q26 | Tomo 04 · 2.2 (Pág. 26) |
| 1.05.1.029 | Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28) |
| 1.05.1.030 | Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29, Q30 | Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28) |
| 1.05.1.031 | Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47, Q48, Q49 | Tomo 04 · 3.3 (Pág. 45) |
| 1.05.1.032 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.1.033 | Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84, Q85, Q86 | Tomo 04 · 5.3 (Pág. 77) |
| 1.05.1.034 | Síndromes mediastínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.1.035 | Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q14 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.1.036 | Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.1.037 | Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q36 | Tomo 04 · 2.5 (Pág. 32) |
| 1.05.1.038 | Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59, Q60, Q62 | Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58) |
| 1.05.2.001 | Asfixia por inmersión | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 04 · C.23 (Pág. 50) |
| 1.05.2.002 | Aspiración de cuerpo extraño con asfixia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.2.003 | Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.2.004 | Crisis Asmática en el Adulto | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q8, Q9, Q10 | Tomo 04 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.05.2.005 | Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68, Q69 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.05.2.006 | Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 04 · 1.5 (Pág. 15) |
| 1.05.2.007 | Hemoptisis y Bronquiectasias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q72 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.2.008 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |
| 1.05.2.009 | Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77, Q78, Q79, Q81 | Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71) |
| 1.05.2.010 | Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q88, Q89, Q90 | Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79) |
| 1.05.2.011 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q51, Q52 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.2.012 | Paro cardiorespiratorio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.2.013 | Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial** | GES | Q51, Q53 | Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47) |
| 1.05.2.014 | Traumatismo torácico simple | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8) |
| 1.05.4.001 | Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7 | Tomo 04 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.5.005 | Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57 | Tomo 04 · 4.1 (Pág. 56) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

PREGUNTA 1 1.05.2.002

**1.** **[URGENCIA: Aspiración de cuerpo extraño con asfixia · 1.05.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aspiración de cuerpo extraño con asfixia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 2 1.05.2.003

**2.** **[URGENCIA: Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia · 1.05.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 3 1.05.1.009

**3.** **Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Suspender amiodarona

B) Solicitar TAC de tórax

C) Aumentar diurético

D) Solicitar ecocardiograma

E) Solicitar fibrobroncoscopia

PREGUNTA 4 1.05.1.020

**4.** **Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Quiste hidatídico pulmonar

B) Absceso pulmonar

C) Bronquiectasias

D) Cáncer pulmonar cavitado

E) Aspergilosis pulmonar invasiva

PREGUNTA 5 1.05.1.021

**5.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hipertensión pulmonar · 1.05.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hipertensión pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 1.05.4.001

**6. Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y disnea sibilante tras realizar ejercicio. Se realiza una espirometría basal que muestra VEF1/CVF de 0.64 y VEF1 del 68% del teórico. Tras la inhalación de 400 mcg de salbutamol, el VEF1 asciende al 84% del predicho, con un incremento absoluto de 420 mL. ¿Cuál es la interpretación diagnóstica más adecuada?**

A) Patrón restrictivo pulmonar puro secundario a hiperreactividad
B) Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma
C) Obstrucción fija de la vía aérea que descarta asma bronquial
D) Espirometría no interpretable que exige solicitar pletismografía inmediata
E) Patrón mixto con atrapamiento aéreo severo

PREGUNTA 7 1.05.4.001

**7. Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62% del valor predicho y CVF del 60% del predicho. ¿Cuál es la conducta médica de elección para certificar el diagnóstico funcional?**

A) Iniciar salmeterol con fluticasona por patrón obstructivo leve
B) Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)
C) Realizar test de provocación con metacolina en forma ambulatoria
D) Asumir diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar e iniciar pirfenidona
E) Repetir la espirometría tras ciclo de prednisona oral por 14 días

PREGUNTA 8 1.05.2.004

**8. Un paciente de 25 años, con antecedente de asma en tratamiento con flu8casona, un puff cada 12 horas, y salbutamol SOS, consulta por un cuadro de disnea que inició hace 48 horas en relación a un cuadro respiratorio alto y que ha ido empeorando, presentando actualmente disnea de mínimos esfuerzos que no ha respondido al uso de salbutamol. Al examen Fsico se observa taquipneico, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, frecuencia respiratoria de 35 por minuto, saturación de oxígeno 95% y frases con palabras entrecortadas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para precisar la severidad del cuadro?**

A) Radiogra:a de tórax
B) Test de metacolina
C) Flujo espiratorio máximo (PEF)
D) Hemograma y VHS
E) Gases en sangre venosa

PREGUNTA 9 1.05.2.004

**9. Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra somnoliento, sudoroso, con respiración paradójica y a la auscultación pulmonar llama la atención un murmullo pulmonar globalmente disminuido sin sibilancias audibles ("tórax silente"). Los gases arteriales muestran: pH 7.28, PaO2 55 mmHg, PaCO2 48 mmHg y HCO3 22 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica y la conducta más prioritaria?**

A) Mejoría clínica espontánea por ausencia de sibilancias; mantener observación con salbutamol en dosis bajas
B) Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal
C) Ataque de pánico con hiperventilación psicógena; administrar alprazolam oral
D) Acidosis metabólica láctica primaria; administrar 100 mL de bicarbonato de sodio EV
E) Crisis leve-moderada compensada; nebulizar con suero fisiológico exclusivo

PREGUNTA 10 1.05.2.004

**10. Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO2 94% ambiental y PEF del 62% del valor predicho. Tras recibir salbutamol 4 puff cada 20 minutos por 3 veces y 40 mg de prednisona oral, se encuentra asintomática, con SatO2 97% y PEF del 78%. ¿Cuál es la indicación farmacológica de egreso más apropiada?**

A) Salbutamol a demanda exclusivo sin corticoides ambulatorios
B) Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico
C) Ciclo de prednisona oral por 30 días con reducción progresiva semanal
D) Amoxicilina más ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
E) Teofilina de liberación prolongada 200 mg cada 12 horas

PREGUNTA 11 1.05.1.002

**11. Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg cada 12 horas más salbutamol SOS. En las últimas 4 semanas refiere haber presentado tos y sibilancias 3 veces por semana, un despertar nocturno por disnea y necesidad de salbutamol 3 veces por semana. No ha tenido limitaciones en su trabajo. ¿Cómo clasifica su nivel de control y cuál es la conducta clínica inicial?**

A) Asma bien controlada; reducir la fluticasona a la mitad
B) Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA
C) Asma no controlada; iniciar de inmediato prednisona oral 40 mg al día por 1 mes
D) Asma refractaria grave; derivar a nivel secundario para estudio con anticuerpos monoclonales
E) Crisis asmática subaguda; hospitalizar en sala de medicina interna

PREGUNTA 12 1.05.1.003

**12.** **Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquiectasias
D) Bronquitis crónica
E) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

PREGUNTA 13 1.05.1.006

**13.** **Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de pulmón
B) Tuberculosis pulmonar
C) Fibrosis pulmonar
D) EPOC
E) Bronquitis crónica

PREGUNTA 14 1.05.1.035

**14.** **Un paciente de 36 años consulta por sensación de opresión precordial y tos, que son más intensas en la noche. Además, refiere disfonía y rinorrea, que se exacerbó durante la primavera. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar omeprazol oral
B) Iniciar antihistamínicos orales
C) Iniciar corticoides orales
D) Iniciar antibióticos orales
E) Iniciar AINEs orales

PREGUNTA 15 1.05.1.016

**15.** **Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra en reposo, en fase estable. Su gasometría arterial respirando aire ambiental muestra: pH 7.38, PaO2 53 mmHg, PaCO2 46 mmHg y SatO2 86%. ¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado prolongar la supervivencia en este paciente?**

A) Terapia triple con fluticasona, salmeterol y tiotropio
B) Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día
C) Ciclos mensuales de azitromicina oral en dosis profiláctica
D) Teofilina oral de liberación retardada
E) Nebulizaciones diarias con solución salina hipertónica al 7%

PREGUNTA 16 1.05.1.017

**16.** **Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50%**

A) Fibrosis pulmonar
B) Insuficiencia cardiaca derecha
C) EPOC
D) Asma
E) Bronquiectasias

PREGUNTA 17 1.05.1.005

**17.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bronquitis aguda · 1.05.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bronquitis aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 1.05.2.006

**18.** **Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Su radiografía de tórax se muestra más abajo (fuente: radiopaedia). Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO2: 62 mmHg, PaO2: 56 mmHg, pH:7,29 y HCO3: 27 mEq/L. La conducta más adecuada, a continuación, es:**

A) Ventilación mecánica invasiva
B) Aminofilina endovenosa
C) Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
D) Ventilación no invasiva
E) Bicarbonato de sodio endovenoso

PREGUNTA 19 1.05.1.022

**19.** **Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?**

A) Amoxicilina
B) Aciclovir
C) Acetaminofeno
D) Claritromicina
E) Prednisona

PREGUNTA 20 1.05.1.027

**20.** **Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopuruleta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la trasmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.learningradiology.com ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Oseltamivir
B) Levofloxacino
C) Ceftriaxona
D) Amoxicilina
E) Claritromicina

PREGUNTA 21 1.05.1.027

**21.** **Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración purulenta y fiebre de 39 °C. Al examen físico se encuentra desorientado en tiempo y espacio, con FR de 34 rpm, PA 85/50 mmHg, FC 118 lpm y crepitaciones en la base pulmonar izquierda. La radiografía de tórax confirma una consolidación basal izquierda. El nitrógeno ureico en sangre (BUN) es de 28 mg/dL. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta de internación más adecuada?**

A) CURB-65 de 2 puntos; hospitalización en sala de medicina general
B) CURB-65 de 3 puntos; manejo ambulatorio con control en 24 horas
C) CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
D) CURB-65 de 1 punto; tratamiento ambulatorio con levofloxacino
E) CURB-65 de 4 puntos; hospitalización en sala intermedia sin monitorización

PREGUNTA 22 1.05.1.027

**22.** **¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en un adulto con clínica compatible?**

A) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución
B) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral
C) Tinción de Gram y cultivo de esputo
D) Proteína C reactiva y procalcitonina cuantitativa
E) Espirometría basal

PREGUNTA 23 1.05.1.027

**23.** **Hombre de 66 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en un centro de salud familiar por cuadro de 48 horas de fiebre hasta 38.5 °C, tos productiva con esputo amarillento y dolor pleurítico en hemitórax derecho. Al examen: vigil, orientado en tiempo y espacio, FC 84 lpm, PA 126/78 mmHg, FR 20 rpm, SatO2 96% ambiental. Murmullo pulmonar conservado con crépitos inspiratorios en base derecha. BUN 12 mg/dL. Radiografía de tórax: infiltrado alveolar basal derecho. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta recomendada?**

A) CURB-65 = 0 puntos; manejo sintomático con paracetamol sin antibióticos
B) CURB-65 = 1 punto; tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico oral y control clínico en 48 horas
C) CURB-65 = 2 puntos; hospitalización obligatoria en sala de cuidados medios
D) CURB-65 = 1 punto; derivación inmediata a urgencias para administración de ceftriaxona endovenosa
E) CURB-65 = 3 puntos; ingreso directo a Unidad de Cuidados Intensivos

PREGUNTA 24 1.05.1.027

**24.** **¿Cuál de los siguientes criterios clínicos constituye un criterio mayor de la Sociedad Americana del Tórax (ATS/IDSA) que define por sí solo el ingreso directo a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad?**

A) Frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto
B) Presencia de infiltrados alveolares multilobares en la radiografía de tórax
C) Shock séptico con necesidad de soporte con vasopresores a pesar de resucitación con fluidos
D) Relación PaO2/FiO2 menor o igual a 250
E) Confusión mental aguda con desorientación témporo-espacial

PREGUNTA 25 1.05.1.028

**25.** **Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por fiebre de 38.5 °C, tos productiva y decaimiento de 48 horas. Al examen: orientada, PA 135/85 mmHg, FC 88 lpm, FR 20 rpm, SatO2 95% ambiental. La radiografía de tórax confirma neumonía basal derecha. ¿Cuál es el esquema antibiótico ambulatorio de primera línea según las guías clínicas ministeriales (GES)?**

A) Ceftriaxona 1 g intramuscular al día por 14 días
B) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por vía oral por 3 días
D) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días
E) Cotrimoxazol fuerte 1 comprimido cada 12 horas por 14 días

PREGUNTA 26 1.05.1.028

**26.** **Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2. Recibe ceftriaxona 1 g EV al día. Al cuarto día de hospitalización se encuentra afebril desde hace 48 horas, con FR 16 rpm, FC 74 lpm, PA 125/80 mmHg y SatO2 96% ambiental, tolerando alimentación por boca. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?**

A) Mantener la ceftriaxona endovenosa hasta completar estrictamente 14 días
B) Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroximo) para completar 7 días totales
C) Suspender antibióticos y solicitar nueva radiografía de tórax para comprobar la resolución del infiltrado antes del alta
D) Cambiar ceftriaxona a vancomicina oral profiláctica
E) Tomar broncoscopía con lavado broncoalveolar para cultivo

PREGUNTA 27 1.05.1.029

**27.** **Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Fibrosis pulmonar
B) Asma bronquial
C) Neumonitis viral
D) Neumonía por mycoplasma
E) Neumonía por Pneumocystis jiroveci

PREGUNTA 28 1.05.1.029, 1.05.1.030

**28.** **Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina en bolo intramuscular diario
E) Fluconazol endovenoso

PREGUNTA 29 1.05.1.029, 1.05.1.030

**29.** **Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38.6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en base pulmonar izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?**

A) Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días
B) Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam
C) Diagnóstico de embolia grasa; administrar corticoides a altas dosis
D) Diagnóstico de bronquitis aguda viral; mantener observación sin antimicrobianos
E) Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

PREGUNTA 30 1.05.1.030

**30.** **Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina en bolo intramuscular diario
E) Fluconazol endovenoso

PREGUNTA 31 1.05.1.001

**31.** **Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A) Broncoscopía
B) Videotoracoscopía
C) TAC de tórax
D) PET-TC
E) Resonancia magnética nuclear de tórax

PREGUNTA 32 1.05.1.001, 1.05.1.008

**32. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?**

A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

PREGUNTA 33 1.05.1.001, 1.05.1.008

**33. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a sospechar un carcinoma epidermoide cavitado antes que un absceso bacteriano simple?**

A) Presencia de esputo fétido con olor a putrefacción
B) Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC
C) Aparición aguda en menos de 48 horas con fiebre alta
D) Resolución completa de la lesión tras dos semanas de penicilina
E) Antecedente de extracción de piezas dentales hace 10 días

PREGUNTA 34 1.05.1.008

**34. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?**

A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

PREGUNTA 35 1.05.1.036

**35. Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar profilaxis antituberculosa
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
C) Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso
D) Solicitar cultivo de Koch
E) Solicitar PPD

PREGUNTA 36 1.05.1.037

**36. Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar RHZE bajo supervisión directa. A las 4 semanas de tratamiento consulta refiriendo disminución progresiva de la agudeza visual y dificultad para distinguir las luces del semáforo, refiriendo ver los colores deslavados. ¿Cuál de los fármacos del esquema es el responsable más probable de este cuadro?**

A) Isoniazida
B) Rifampicina
C) Etambutol
D) Pirazinamida
E) Estreptomicina

## BLOQUE 3 PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

PREGUNTA 37 1.05.2.014

**37. [URGENCIA: Traumatismo torácico simple · 1.05.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo torácico simple. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 38 1.05.1.010

**38.** **Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
B) Broncoscopía con biopsia pulmonar
C) PET-TC
D) Biopsia pleural por videotoracoscopía
E) Broncoscopía con lavado bronquioalveolar

PREGUNTA 39 1.05.1.010

**39.** **Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural derecho. Los resultados del líquido pleural y sérico simultáneo arrojan: Proteínas en líquido pleural 2.1 g/dL, Proteínas en suero 6.4 g/dL; LDH en líquido pleural 90 U/L, LDH en suero 210 U/L (límite superior normal de LDH sérica: 200 U/L). ¿Cuál es la clasificación del líquido pleural y la etiología más probable?**

A) Exudado; empiema paraneumónico
B) Exudado; adenocarcinoma metastásico
C) Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada
D) Exudado; pleuritis lúpica
E) Quilotórax traumático

PREGUNTA 40 1.05.1.010

**40.** **¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo en la base pulmonar comprometida?**

A) Aumento de las vibraciones vocales y timpanismo marcado
B) Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular
C) Resonancia vocal incrementada (broncofonía) con estertores húmedos bilaterales
D) Frote pericárdico con murmullo pulmonar conservado
E) Sonoridad pulmonar aumentada con respiración ruda y sibilancias difusas

PREGUNTA 41 1.05.1.011

**41.** **Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm3, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar drenaje completo del derrame pleural
B) Agregar metronidazol al tratamiento
C) Solicitar TAC de tórax
D) Solicitar baciloscopías de expectoración
E) Realizar broncoscopia y biopsia

PREGUNTA 42 1.05.1.011, 1.05.1.012

**42.** **Un paciente de 62 años hospitalizado hace 4 días por neumonía comunitaria en tratamiento con ceftriaxona endovenosa persiste con picos febriles de 38.8 °C y marcado compromiso del estado general. La ecografía torácica evidencia un derrame pleural de 300 mL en la base derecha. Se realiza toracocentesis diagnóstica obteniendo líquido turbio cuyo análisis muestra: pH 7.14, glucosa 32 mg/dL, LDH 2.200 U/L, proteínas 4.5 g/dL. La tinción de Gram inmediata no observa bacterias. ¿Cuál es la conducta médica de elección más prioritaria?**

A) Mantener ceftriaxona en la misma dosis y repetir la punción diagnóstica en 48 horas
B) Instalar de inmediato un tubo de drenaje torácico conectado a trampa de agua
C) Suspender ceftriaxona e iniciar monoterapia con ciprofloxacino oral
D) Indicar toracotomía abierta de urgencia con decorticación pulmonar
E) Realizar kinesioterapia respiratoria intensiva y administrar diuréticos de asa

PREGUNTA 43 1.05.1.011, 1.05.1.012

**43.** **¿Cuál de los siguientes parámetros del análisis físico-químico del líquido pleural es el indicador individual más confiable y determinante para decidir la instalación de un tubo de drenaje pleural en un derrame paraneumónico?**

A) Recuento absoluto de glóbulos blancos mayor a 10.000/uL
B) pH del líquido pleural inferior a 7.20
C) Relación de proteínas líquido pleural / suero mayor a 0.5
D) Nivel de amilasa pleural elevado al doble del plasma
E) Concentración de adenosina deaminasa (ADA) superior a 30 U/L

PREGUNTA 44 1.05.1.011, 1.05.1.012

**44.** **Hombre de 48 años con antecedentes de enolismo crónico es diagnosticado de empiema pleural derecho con abundante pus espeso y fétido al examen de toracocentesis. Se instala un tubo de drenaje pleural 28 Fr con salida inicial de 400 mL de material purulento. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana parenteral de primera línea más adecuada?**

A) Ciprofloxacino en monoterapia
B) Ampicilina / Sulbactam endovenoso (o Ceftriaxona asociada a Metronidazol)
C) Gentamicina endovenosa en dosis única diaria
D) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas
E) Azitromicina endovenosa exclusiva

PREGUNTA 45 1.05.1.011, 1.05.1.012

**45.** **Paciente de 55 años con empiema pleural derecho complicado tiene instalado un tubo de drenaje torácico hace 48 horas. Sin embargo, el débito ha disminuido a menos de 50 mL/día a pesar de persistir con fiebre de 38.5 °C y leucocitosis de 18.000/uL. La ecografía torácica de control demuestra múltiples tabiques gruesos de fibrina con colecciones loculadas que no comunican con el tubo. ¿Cuál es el paso terapéutico más indicado?**

A) Retirar el tubo de tórax y mantener únicamente antibioticoterapia oral en domicilio
B) Instilación intrapleural de fibrinolíticos combinados (t-PA más DNAsa) o resolución por videotoracoscopía (VATS)
C) Punción pleural diaria repetida con aguja fina en la consulta
D) Aumentar la hidratación parenteral a 4.000 mL de suero fisiológico al día
E) Indicar reposo absoluto y esperar 14 días para la reabsorción espontánea

PREGUNTA 46 1.05.1.012

**46.** **Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo: NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. ¿Qué antibiótico debe dejar?**

A) Claritromicina
B) Clindamicina
C) Ceftriaxona
D) Azitromicina
E) Amoxicilina

PREGUNTA 47 1.05.1.031

**47.** **Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:**

A) Angina inestable
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Neumotorax espontáneo
D) Perforación esofágica
E) Contractura muscular

PREGUNTA 48 1.05.1.031

**48.** **Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico izquierdo agudo iniciado en reposo. Al examen físico: SatO2 99% respirando aire ambiental, FR 16 rpm, PA 118/70 mmHg, murmullo pulmonar levemente disminuido en el ápice izquierdo. La radiografía de tórax muestra una franja de aire apical de 1.2 cm en el hemitórax izquierdo sin desviación mediastínica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Instalación inmediata de un tubo de drenaje pleural número 28 Fr con trampa de agua
B) Toracotomía exploradora de urgencia para resección de bullas
C) Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico
D) Punción pleural descompresiva en el segundo espacio intercostal con bránula 14G
E) Alta inmediata sin necesidad de reposo ni seguimiento

PREGUNTA 49 1.05.1.031

**49.** **¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante videotoracoscopía (VATS) y pleurodesis en un paciente con neumotórax espontáneo primario?**

A) Primer episodio de neumotórax primario de 1 cm resuelto favorablemente
B) Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)
C) Paciente fumador pasivo con tos crónica sin neumotórax
D) Presencia de dolor pleurítico residual leve a los 3 días del alta
E) Aparición de frote pleural durante la fase de reexpansión

PREGUNTA 50 1.05.1.032

**50.** **Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (Fuente: imgur.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control radiológico en 24 horas
B) Solicitar TAC de tórax
C) Realizar cirugía abierta
D) Drenaje con tubo pleural
E) Realizar videotoracoscopía

PREGUNTA 51 1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013

**51. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?**

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 52 1.05.2.011

**52. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?**

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 53 1.05.2.013

**53. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?**

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 54 1.05.1.013

**54. Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La radiografía muestra derrame pleural derecho moderado. El estudio del líquido pleural confirma un exudado seroso con 92% de células mononucleares (linfocitos), glucosa de 68 mg/dL y un nivel de ADA pleural de 62 U/L. La tinción de Ziehl-Neelsen del líquido pleural no observa bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Cuál es el examen confirmatorio con mayor rendimiento diagnóstico para esta patología?**

A) Repetir la baciloscopía del líquido pleural en tres muestras consecutivas
B) Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo
C) PPD (tuberculina) dérmico exclusiva sin biopsia
D) Resonancia magnética de tórax con contraste paramagnético
E) Broncoscopía con lavado broncoalveolar

## BLOQUE 4 ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

PREGUNTA 55 1.05.1.034

**55. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mediastínicos · 1.05.1.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mediastínicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 1.05.1.008, 1.05.5.005

**56. Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax revela una opacidad redondeada homogénea de 12 mm en el lóbulo superior izquierdo sin otras anomalías. La paciente refiere que hace 3 años se tomó una radiografía de tórax por un chequeo laboral preventivo en su empresa. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Realizar punción percutánea inmediata bajo visión ecográfica
B) Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión
C) Indicar tratamiento con levofloxacino por 14 días y radiografía al término
D) Programar lobectomía superior izquierda por sospecha de adenocarcinoma
E) Indicar broncoscopía rígida con biopsia transbronquial

PREGUNTA 57 1.05.1.008, 1.05.5.005

**57.** **¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es patognomónico de un hamartoma pulmonar benigno?**

A) Calcificación excéntrica milimétrica en la periferia de la lesión
B) Calcificaciones punteadas amorfas difusas
C) Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa
D) Calcificación en anillo de sello pleuropulmonar
E) Calcificación distrófica con nivel hidroaéreo

PREGUNTA 58 1.05.1.007

**58.** **Un paciente de 66 años, hipertenso, fumador de 40 paquetes-año consulta por un cuadro de tos, de 2 meses de evolución, con expectoración mucosa o mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica asociados a baja de peso. Al examen físico, tiene disminución del murmullo pulmonar bilateral, mayor a derecha, con crepitaciones pulmonar en el lado derecho. Se palpan adenopatías supraclaviculares bilaterales y se constata hipocratismo digital. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,5 g/dl, leucocitos: 11.000 por mm3, plaquetas: 140.000 por mm3. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.medicinainternaaldia.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumonía multifocal
B) Quiste hidatídico
C) Atelectasia
D) Derrame pleural
E) Cáncer pulmonar

PREGUNTA 59 1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

**59.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihiliar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
D) Hamartoma pulmonar central
E) Tumor carcinoide típico bronquial

PREGUNTA 60 1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

**60.** **Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. ¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?**

A) Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar
B) Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado
C) Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha
D) Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua
E) Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

PREGUNTA 61 1.05.1.025

**61.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihiliar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
D) Hamartoma pulmonar central
E) Tumor carcinoide típico bronquial

PREGUNTA 62 1.05.1.038

**62.** **Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente: La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Solicitar TAC de tórax
B) Realizar punción transpleural
C) Instalar tubo pleural con trampa de agua
D) Realizar toracocentesis diagnóstica
E) Realizar broncoscopía rígida

PREGUNTA 63 1.05.1.018

**63.** **Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probrable es:**

A) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B) Tuberculosis
C) Enfermedad pulmonar intersticial difusa
D) Cáncer pulmonar
E) Tromboembolismo pulmonar crónico

PREGUNTA 64 1.05.1.018, 1.05.1.026

**64.** **Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al caminar media cuadra, acompañada de tos seca. Al examen físico destacan dedos en palillo de tambor y crepitaciones secas bilaterales en ambas bases pulmonares en velcro. La espirometría muestra una relación VEF1/CVF de 0.84 con CVF del 56% del predicho. La TACAR de tórax muestra patrón de panalización subpleural y basal bilateral sin vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta farmacológica correcta?**

A) Neumonitis por hipersensibilidad; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día
B) Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)
C) Sarcoidosis pulmonar estadio IV; iniciar metotrexato oral
D) Insuficiencia cardíaca izquierda; indicar furosemida endovenosa
E) EPOC enfisematoso; iniciar broncodilatadores inhalados LAMA + LABA

PREGUNTA 65 1.05.1.018, 1.05.1.026

**65.** **¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad pulmonar subaguda con patrón intersticial difuso en la tomografía computarizada?**

A) Enalapril
B) Amiodarona
C) Aspirina
D) Atorvastatina
E) Amlodipino

PREGUNTA 66 1.05.1.026

**66.** **Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año, pero que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: NOTA: la radiografía inicial mostraba infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales, onduladas de 1-2 cm en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Bronquitis crónica
B) Neumoconiosis
C) Cáncer de pulmón
D) Limitación crónica del flujo aéreo
E) Fibrosis pulmonar idiopática

PREGUNTA 67 1.05.1.015

**67.** **Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Empiema
B) Derrame paraneumónico simple
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Transudado pleural
E) Compromiso pleural maligno

PREGUNTA 68 1.05.1.015, 1.05.2.005

**68.** **Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea súbita de 2 horas de evolución. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente inestable: somnoliento, pálido, sudoroso, con PA 75/45 mmHg, FC 126 lpm y SatO2 84% con oxígeno ambiental. El ecocardiograma portátil a la cabecera del paciente muestra dilatación severa del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre y colapso del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?**

A) Iniciar infusión de heparina no fraccionada y hospitalizar en sala común
B) Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)
C) Instalar filtro de vena cava inferior en forma percutánea urgente
D) Administrar 3.000 mL de solución salina fisiológica al 0.9% en bolo rápido
E) Iniciar anticoagulación oral con rivaroxabán a dosis de 15 mg cada 12 horas

PREGUNTA 69 1.05.2.005

**69.** **Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía de tórax
B) TAC de tórax
C) Dímero D
D) Ecocardiograma
E) AngioTAC de tórax

PREGUNTA 70 1.05.1.004

**70.** **Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repe8ción y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y produc8va, mayor durante las mañanas, con expectoración mucosa y, en ocasiones, hemoptoica. Al examen Fsico presenta dedos en palillo de tambor (acropaquias), frecuencia cardíaca 75 lpm y presión arterial 110/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar revela ritmo regular en dos tonos sin soplos, murmullo pulmonar presente y simétrico, con auscultación de crepitaciones y estertores bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Bronqui2s crónica
B) Bronquiectasias
C) Carcinoma broncogénico
D) Tuberculosis pulmonar
E) Insuficiencia cardíaca conges2va

PREGUNTA 71 1.05.1.019

**71.** **Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
E) Posición genupectoral

PREGUNTA 72 1.05.2.007

**72.** **Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
E) Posición genupectoral

## BLOQUE 5 CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

PREGUNTA 73 1.05.2.001

**73.** **[URGENCIA: Asfixia por inmersión · 1.05.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Asfixia por inmersión. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 74 1.05.2.012

**74.** **[URGENCIA: Paro cardiorespiratorio · 1.05.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 1.05.1.023

**75.** **Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?**

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 76 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

**76.** **Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?**

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 77 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

**77. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una falta de respuesta (o refractariedad) a la administración de oxígeno suplementario al 100% mediante mascarilla de no reinhalación?**

A) Desbalance ventilación-perfusión con zonas de bajo V/Q
B) Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero
C) Hipoventilación alveolar por intoxicación por benzodiacepinas
D) Disminución de la presión barométrica en grandes alturas
E) Limitación de la difusión en ejercicio

PREGUNTA 78 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

**78. Una mujer de 64 años ingresa al servicio de urgencias por disnea progresiva, tos y fiebre. Al examen: FR 28 rpm, SatO2 86% respirando aire ambiental. Sus gases arteriales a nivel del mar muestran: pH 7.45, PaO2 52 mmHg, PaCO2 32 mmHg y HCO3 22 mEq/L. Con una presión barométrica de 760 mmHg y vapor de agua de 47 mmHg, el cálculo del Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno resulta en 58 mmHg (marcadamente elevado). ¿Qué conclusión diagnóstica fisiopatológica se deriva de este resultado?**

A) Hipoxemia por hipoventilación alveolar pura secundaria a debilidad de musculatura diafragmática
B) Hipoxemia dependiente de alteración del parénquima pulmonar o del lecho vascular (desbalance V/Q o shunt)
C) Insuficiencia respiratoria crónica compensada con integridad del alvéolo
D) Efecto secundario normal esperado para la edad de la paciente
E) Hipoxemia explicable exclusivamente por una disminución de la fracción inspirada de oxígeno ambiental

PREGUNTA 79 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

**79. Un paciente de 68 años con antecedente de EPOC grave ingresa a urgencias por disnea de reposo, tos con expectoración purulenta y compromiso cuantitativo de conciencia fluctuante con asterixis. Al examen físico: somnoliento, diaforético, FR 32 rpm con respiración con labios fruncidos y uso de esternocleidomastoideos. Gases arteriales con mascarilla Venturi al 28%: pH 7.27, PaO2 56 mmHg, PaCO2 66 mmHg, HCO3 30 mEq/L. ¿Cuál es el soporte ventilatorio de primera línea con mayor nivel de evidencia para evitar la intubación orotraqueal y disminuir la mortalidad?**

A) Aumento inmediato de la FiO2 al 100% mediante mascarilla con reservorio
B) Ventilación Mecánica No Invasiva con presión positiva binivelada (VMNI BiPAP)
C) Intubación orotraqueal y conexión directa a ventilador mecánico invasivo
D) Infusión endovenosa continua de aminofilina a dosis de carga
E) Administración de bicarbonato de sodio 2/3 molar endovenoso para corregir el pH

PREGUNTA 80 1.05.2.008

**80. Un paciente presenta una neumonía, con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Satura 75% a FiO2 ambiental y tiene gases arteriales, con una presión arterial de O2 de 54 mmHg y presión de CO2 de 32 mmHg. ¿Cómo debe administrarse el oxígeno a este paciente?**

A) Por naricera a 0,5 litros por minuto
B) Por naricera a 2 litros por minuto
C) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 24%
D) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 40%
E) Por ventilación mecánica invasiva

PREGUNTA 81 1.05.2.009

**81. Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?**

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 82 1.05.1.014

**82. Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO2 70% y PEEP 8 cmH2O, sus gases arteriales reportan una PaO2 de 63 mmHg (PaFiO2 = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?**

A) SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real
B) SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz
C) Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina
D) Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopía rígida desobstructiva
E) SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

PREGUNTA 83 1.05.1.014

**83. ¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH2O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA?**

A) Presión inspiratoria peak (Ppeak)
B) Presión meseta o plateau (Pplateau)
C) Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)
D) Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)
E) Presión venosa central (PVC)

PREGUNTA 84 1.05.1.033

**84. Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apenas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Oxígeno nocturno
B) C-PAP nocturno
C) Cirugía bariátrica
D) Uvulopalatoplastía
E) Dispositivo orofaríngeo

PREGUNTA 85 1.05.1.033

**85. Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta médica traído por su cónyuge. Ella relata que el paciente ronca sonoramente todas las noches y que en reiteradas ocasiones observa que deja de respirar por varios segundos, finalizando el episodio con un ronquido explosivo. El paciente refiere cansancio crónico diurno y somnolencia mientras maneja su automóvil. Su escala de Epworth es de 15 puntos. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para confirmar la enfermedad?**

A) Electroencefalograma estándar de vigilia
B) Polisomnografía nocturna
C) Holter de presión arterial de 24 horas
D) Espirometría con curva de flujo-volumen
E) Tomografía computarizada de cavidades paranasales

PREGUNTA 86 1.05.1.033

**86. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado mediante polisomnografía de un SAHOS severo con un IAH de 38 eventos por hora?**

A) Fármacos estimulantes diurnos como modafinilo en monoterapia
B) Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)
C) Uvulopalatofaringoplastía quirúrgica de urgencia
D) Oxigenoterapia nocturna exclusiva por cánula nasal a 2 L/min
E) Prescripción de clonazepam nocturno para regularizar el ciclo del sueño

PREGUNTA 87 1.05.1.024

**87. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?**

A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

PREGUNTA 88 1.05.1.024, 1.05.2.010

**88. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?**

A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

PREGUNTA 89 1.05.1.024, 1.05.2.010

**89. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye una indicación formal e indiscutida de traslado urgente a una unidad de Oxigenoterapia Hiperbárica (Cámara Hiperbárica)?**

A) Paciente no fumador con nivel de carboxihemoglobina de 8% y cefalea leve
B) Paciente masculino joven con COHb de 12% que responde adecuadamente al oxígeno normobárico
C) Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición
D) Paciente con tos seca irritativa sin acidosis
E) Fumador crónico con carboxihemoglobina de 9% asintomático

PREGUNTA 90 1.05.2.010

**90.** **Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a humo durante un incendio en su casa. Al examen Fsico registra frecuencia cardíaca 100 lpm, presión arterial 130/85 mmHg, frecuencia respiratoria 35 rpm y saturación de oxígeno de 96%. No presenta cianosis ni uso de musculatura accesoria, y su examen cardiopulmonar es normal. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

**A)** Radiogra:a de tórax
**B)** TAC de tórax
**C)** Niveles de carboxihemoglobina
**D)** Gases en sangre arterial
**E)** Monitorización transcutánea de niveles de anhídrido carbónico

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

**Aspiración de cuerpo extraño con asfixia**

1.05.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aspiración de cuerpo extraño con asfixia" como urgencia clínica (1.05.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A

**Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia" como urgencia clínica (1.05.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A

**Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar**

1.05.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

**Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar**

1.05.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Quiste hidatídico pulmonar

### PREGUNTA 5 Respuesta: A

**Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar**

1.05.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hipertensión pulmonar" (1.05.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 6 Respuesta: B

**Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar**

1.05.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una relación VEF1/CVF < 0.70 basal que revierte tras broncodilatador con un aumento de VEF1 > 12% y > 200 mL (en este caso 420 mL y 16% absoluto), normalizando la función. Este patrón obstructivo reversible es característico y diagnóstico de asma bronquial. La restricción (A) cursa con relación VEF1/CVF normal. No es una obstrucción fija (C) porque revirtió significativamente.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

1.05.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar**

Una espirometría con relación VEF1/CVF normal (≥ 0.70) y CVF disminuida (< 80%) es sugerente pero NO diagnóstica de alteración restrictiva. Para confirmar fehacientemente una restricción pulmonar es indispensable medir volúmenes absolutos mediante pletismografía corporal y constatar una CPT < 80%. Asumir fibrosis o indicar fármacos sin CPT es un error conceptual grave.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Crisis Asmática en el Adulto**

La severidad de la crisis asmática se determina en base a la clínica. Dentro de los exámenes, son úGles tanto el PEF como los gases en sangre arterial (no venosa, ya que la PaO2 arterial es el parámetro que define el manejo) y suelen pedirse ambos. El PEF suele ser el inicial y más importante para objetivar y seguir el grado de obstrucción y respuesta al tratamiento. Los GSA se solicitan especialmente cuando la crisis es muy severa y hay signos de insuficiencia respiratoria. Los GSA son mucho más importantes en el EPOC descompensado, en que Gende a la hipercarbia y definen la necesidad de ventilación mecánica. En el asma, en cambio, la clínica y el PEF muchas veces son suficientes.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Crisis Asmática en el Adulto**

El paciente presenta signos inequívocos de crisis asmática casi fatal con agotamiento muscular inminente: tórax silente (flujo aéreo insuficiente para generar sibilancias), somnolencia y acidosis respiratoria con hipercapnia (PaCO2 48 mmHg). Normalmente el asma hiperventila y genera hipocapnia (PaCO2 < 35); cuando la PaCO2 se normaliza o sube, el paciente está claudicando y requiere manejo en reanimación con preparación de intubación orotraqueal e ingreso a UCI.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Crisis Asmática en el Adulto**

Tras una crisis asmática moderada resuelta en urgencias, todo paciente debe ser dado de alta con un ciclo corto de corticoide sistémico oral (Prednisona 40–50 mg/día por 5 a 7 días) para prevenir recaídas precoces y consolidar la desinflamación bronquial. Los ciclos cortos (< 14 días) no requieren reducción gradual. Los antibióticos (D) no están indicados en crisis asmáticas no infecciosas y la teofilina (E) está en desuso.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES**

La paciente cumple 2 criterios positivos en las últimas 4 semanas (síntomas diurnos > 2/sem y rescate > 2/sem, además de un despertar nocturno), lo que clasifica su condición como "Asma parcialmente controlada" según GINA. La conducta protocolar obligatoria antes de cualquier cambio de receta es verificar la técnica del uso del inhalador (con aerocámara si es MDI) y comprobar la adherencia terapéutica. Si son correctas, se escala a Escalón 3 agregando un LABA (Salmeterol o Formoterol).

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

1.05.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES**

Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: E**

1.05.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES**

Es una bronquitis crónica clásica: fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana. No tiene EPOC, porque su espirometría está normal. Asimismo, la radiografía normal hace improbables las demás opciones. Finalmente, la clínica no es sugerente de ninguna de las otras.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

1.05.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 160). Evalúa el manejo clínico de Tos crónica según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

1.05.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable**

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria crónica con PaO2 en reposo ≤ 55 mmHg (53 mmHg), cumpliendo el criterio formal de indicación de Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria (OCD). La OCD utilizada un mínimo de 15 horas diarias (idealmente > 16-18 h, incluyendo el sueño) es una de las pocas medidas que ha demostrado de manera contundente reducir la mortalidad y la progresión a cor pulmonale en EPOC.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

1.05.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable**

Patrón obstructivo severo no reversible = EPOC

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bronquitis aguda" (1.05.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: D**

1.05.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)**

Tiene un EPOC descompensado. Además, por tener hipercarbia mayor a 50, está indicado el apoyo ventilatorio, en este caso no invasivo, por no tener compromiso de conciencia. Los gases muestran una insuficiencia respiratoria global (02 < 60 y CO2 > 49), que per sé también se ventila.

---

## BLOQUE 2 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: C**

1.05.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

Parece una influenza u otra infección respiratoria alta, por lo que se trata con paracetamol o acetaminofeno.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: D**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

Tienen una neumonía típica (con condensación del lóbulo inferior izquierdo), adquirida en la comunidad, sin criterios de hospitalización y en un menor de 65 años, sin antecedentes relevantes (la HTA no agrava las neumonías, salvo las por covid-19), por lo que se debe tratar con amoxicilina sola.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: C**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente cumple los 5 criterios del CURB-65: Confusión mental (+1), Urea/BUN > 19 mg/dL (+1 con BUN 28), FR ≥ 30 rpm (+1 con 34 rpm), PA < 90/60 mmHg (+1 con 85/50 mmHg) y Edad ≥ 65 años (+1 con 68 años). Total = 5 puntos. Este puntaje conlleva una mortalidad superior al 40% y define una NAC grave con necesidad inmediata de hospitalización en UCI para monitorización continua, aporte vasoactivo y soporte ventilatorio.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Por definición de consenso nacional e internacional, la confirmación diagnóstica de la neumonía adquirida en la comunidad exige la demostración objetiva de un infiltrado o condensación alveolar nuevo en la Radiografía de tórax (proyecciones frontal y lateral). Los exámenes de laboratorio (PCR, procalcitonina) apoyan la etiología pero no reemplazan la imagen, y el cultivo de esputo (C) no es imprescindible para iniciar el manejo ambulatorio.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente tiene 66 años (≥ 65 años: +1 punto), pero no tiene confusión (0), su BUN es normal (12 mg/dL, corte > 19: 0), su FR es 20 rpm (< 30: 0) y su PA es normal (0). Puntaje CURB-65 = 1 punto. Cuando el único factor presente es la edad en un paciente estable, hemodinámicamente compensado, sin hipoxemia y con adecuado soporte sociofamiliar, la conducta validada por guías MINSAL y GES es el tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico (canasta GES mayores de 65 años) y citación a control clínico a las 48 horas.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: C**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Los criterios ATS/IDSA para NAC severa definen 2 criterios mayores: 1) Shock séptico que requiere vasopresores (noradrenalina); y 2) Insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica invasiva. La presencia de cualquiera de estos dos criterios mayores obliga al ingreso directo a UCI. Las opciones A, B, D y E corresponden a criterios menores de ATS/IDSA, de los cuales se requerirían al menos 3 para justificar el ingreso a UCI.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

**Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES**

1.05.1.028 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente tiene 69 años y comorbilidades médicas crónicas (diabetes e hipertensión), por lo que según las guías chilenas MINSAL/GES el tratamiento ambulatorio de elección es Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas vía oral por 7 días. La amoxicilina simple (C) tiene menor eficacia ante cepas resistentes de neumococo o H. influenzae productor de betalactamasa frecuentes en ancianos. El ciprofloxacino (D) no tiene buena cobertura antineumocócica.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES**

1.05.1.028 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente cumple todos los criterios de estabilidad clínica: afebril > 48 horas, parámetros vitales normales y buena tolerancia enteral. La conducta estándar recomendada es la transición rápida a terapia oral (switch precoz) para completar un curso total de 7 días de antibióticos y dar el alta hospitalaria. No se debe mantener la vía EV innecesariamente (A) ni exigir una radiografía de control para el alta (C), ya que los infiltrados radiológicos tardan de 4 a 8 semanas en limpiar.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: E**

1.05.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa**

Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperinsuflación en asma). La neumonitis viral es aguda.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

1.05.1.029, 1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa**

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino). El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

1.05.1.029, 1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa**

La aparición de síntomas pulmonares e infiltrados nuevos en la radiografía después de las 48 horas de internación hospitalaria define por criterio estricto una Neumonía Intrahospitalaria (NIH). En estos casos, la flora causante incluye microorganismos intrahospitalarios de alta resistencia como Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias multirresistentes. Se debe iniciar de inmediato terapia antibiótica empírica antipseudomónica EV con Piperacilina/Tazobactam o Cefepime tras la toma de cultivos.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa**

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino). El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: C**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares**

Tiene un absceso pulmonar gigante. El manejo es discutible, pero la TAC podrá identificarlo mejor y descartar que haya un cáncer debajo. La broncoscopía también aparece como una opción aceptable, ya que permitiría el drenaje, pero la TAC igualmente debe solicitarse antes y, además, el tratamiento suele ser con clindamicina endovenosa, más drenaje postural, por lo que la broncoscopía solo se hace si falla.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

1.05.1.001, 1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares**

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral). La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

1.05.1.001, 1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares**

Las cavidades de origen neoplásico (frecuentemente carcinoma epidermoide o escamoso central necrosado) se diferencian de los abscesos benignos por tener paredes típicamente muy engrosadas (> 15 mm), contornos internos irregulares, festoneados o con proyecciones nodulares. El esputo fétido (A) y la sepsis dental (E) son propios del absceso anaerobio benigno.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares**

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral). La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

1.05.1.036 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento**

Es un paciente contacto estrecho y sintomático, que, además, ya tiene una prueba positiva para tuberculosis (el quatiferón). Por tanto, aunque tenga las baciloscopías negativas se debe iniciar el tratamiento y no es necesario pedir la PCR.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: C**

1.05.1.037 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento**

El etambutol es el responsable clásico de la neuritis óptica retrobulbar, un efecto adverso dosis-dependiente que se manifiesta por disminución de la agudeza visual central, escotomas centrales y la característica pérdida precoz de la discriminación de los colores rojo y verde (discromatopsia). Ante la aparición de estos síntomas se debe suspender inmediatamente el etambutol y evaluar por oftalmología.

---

## BLOQUE 3 PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Traumatismo torácico simple** 1.05.2.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo torácico simple" como urgencia clínica (1.05.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: D**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light**

Tiene un líquido pleural sugerente de cáncer (exudado: cumple todos los criterios de light; mononuclear; con ADA menor a 30). Dado que la radiografía no muestra un tumor pulmonar, se debe proceder a las biopsias pleurales, las que se hacen por videotoracoscopía y, si no está disponible, de manera percutánea.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: C**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light**

Aplicando los Criterios de Light: Relación Proteínas LP/S = 2.1 / 6.4 = 0.32 (es ≤ 0.5); Relación LDH LP/S = 90 / 210 = 0.42 (es ≤ 0.6); y LDH pleural 90 U/L es inferior a los 2/3 del límite superior sérico (2/3 de 200 = 133 U/L). Al no cumplir ninguno de los tres criterios, se clasifica de forma concluyente como TRASUDADO. La causa más habitual de trasudado en el adulto mayor es la insuficiencia cardíaca congestiva o la hipertensión portal cirrótica.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light**

El síndrome de derrame pleural interpone una capa líquida entre el pulmón y la pared torácica, lo que bloquea la transmisión del sonido y altera la resonancia. Por ello genera la tríada semiológica patognomónica: (1) Abolición o disminución marcada de las vibraciones vocales táctiles, (2) Matidez hídrica franca a la percusión (sin resonancia aérea), y (3) Abolición o disminución extrema del murmullo pulmonar a la auscultación.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

1.05.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

El líquido pleural cumple criterios bioquímicos categóricos de derrame paraneumónico complicado: pH < 7.20 (7.14), glucosa < 40 mg/dL (32 mg/dL) y LDH > 1.000 U/L (2.200 U/L). A pesar de que la tinción de Gram sea inicialmente negativa, la acidosis láctica y el consumo extremo de glucosa certifican actividad bacteriana e inflamatoria intensa en el espacio pleural. La indicación indiscutible es el drenaje pleural inmediato mediante la instalación de un tubo de tórax (pleurostomía cerrada) para evitar la tabicación y el empiema multiloculado.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

El pH del líquido pleural medido en condiciones anaeróbicas es el parámetro bioquímico más sensible y con mayor respaldo en la literatura médica internacional (guías BTS y ACCP) para definir un derrame paraneumónico complicado y la necesidad de drenaje con tubo de tórax. Un pH < 7.20 indica un ambiente intensamente ácido secundario al metabolismo anaerobio bacteriano y leucocitario, lo que predice con más de 95% de precisión que el derrame no se resolverá con antibióticos solos.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: B**

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

En el empiema pleural, especialmente en pacientes con factores de riesgo como alcoholismo crónico, trastornos deglutorios o patología periodontal, existe una alta participación de bacterias anaerobias orales (Fusobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides) asociadas a estreptococos y bacilos gramnegativos. La terapia antibiótica empírica de elección según las guías clínicas nacionales e internacionales es Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV, o la combinación de Ceftriaxona 2 g EV al día más Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV para asegurar cobertura anaerobia sólida.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

Cuando un empiema o derrame paraneumónico complicado se encuentra en fase fibrinopurulenta avanzada con múltiples tabicaciones y loculaciones que impiden el drenaje efectivo por el tubo de pleurostomía, la conducta recomendada es la terapia intrapleural combinada con fibrinolíticos (Alteplasa/t-PA 10 mg + Dornasa alfa/DNAsa 5 mg dos veces al día por 3 días según el protocolo MIST-2) o bien la intervención quirúrgica precoz mediante Cirugía Toracoscópica Videoasistida (VATS) para debridamiento y lisis de adherencias bajo visión directa.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: C**

1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural**

Por ser una neumonía, con derrame (paraneumónico simple en este caso), se debe manejar hospitalizada (ATS III), por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: C**

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario**

Clínica muy sugerente de neumotórax

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: C**

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario**

Se trata de un neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm de separación interpleural) en un paciente completamente estable y asintomático. Las guías clínicas internacionales recomiendan manejo conservador mediante reposo, administración de oxígeno (que aumenta el gradiente para la reabsorción del aire del espacio pleural) y observación médica durante 4 a 6 horas. La punción con bránula (D) es exclusiva del neumotórax a tensión con shock, y el tubo (A) se reserva para neumotórax grandes o sintomáticos.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario**

Tras un primer episodio de neumotórax espontáneo primario, la tasa de recurrencia es del 30%, pero tras un segundo episodio homolateral el riesgo de un tercer evento supera el 50–60%. Por ello, la indicación quirúrgica clásica y de consenso para realizar resección de blebs (bullectomía) asociada a pleurodesis (química o abrasión mecánica) por videotoracoscopía (VATS) es la presencia de un segundo episodio en el mismo lado o la persistencia de fuga aérea por más de 48-72 horas.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

1.05.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático**

Es una pregunta difícil, ya que no se ve bien la radiografía (en el Eunacom original era muy difícil verlo), pero tiene clínica de un neumotórax espontáneo. El manejo es con tubo pleural, pero en los casos en que no hay colapso pulmonar, es posible observarlo, darle analgesia y controlarlo con nuevas radiografías. En este caso, que lleva 2 días sin agravarse, lo más correcto es controlar con radiografía en 24 horas.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático**

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

1.05.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático**

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

1.05.2.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático**

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: B**

**Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa**

1.05.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro clínico y el líquido pleural (exudado mononuclear con ADA > 40 U/L) son altamente sugerentes de pleuritis tuberculosa. Dado que el bacilo de Koch se encuentra en baja cantidad libre en el líquido (baciloscopía líquida positiva en menos del 10%), el método diagnóstico de mayor rendimiento (> 80-90%) es la biopsia pleural con aguja (Cope o Abrams), que permite visualizar los granulomas con necrosis caseosa y cultivar el tejido.

## BLOQUE 4 ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Síndromes mediastínicos**

1.05.1.034 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mediastínicos" (1.05.1.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

**Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner**

1.05.1.008, 1.05.5.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En todo paciente con un nódulo pulmonar solitario recién detectado, el primer paso clínico y con mayor costo-efectividad antes de indicar procedimientos invasivos es buscar y revisar las radiografías o tomografías previas. Si la lesión ya estaba presente y con idéntico tamaño y características hace 2 o 3 años, se confirma la estabilidad y benignidad de la lesión, evitando biopsias, cirugías innecesarias o radiación adicional.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: C**

**Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner**

1.05.1.008, 1.05.5.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hamartoma es la neoplasia benigna más común del pulmón. Su hallazgo clásico en la tomografía computarizada de alta resolución es la presencia de una lesión bien delimitada que contiene calcificaciones internas gruesas dispuestas en "palomitas de maíz" (popcorn) y áreas focales hipodensas de tejido adiposo (densidad entre -40 y -120 UH). Esta combinación confirma categóricamente el origen benigno sin requerir resección.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: E**

**Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial**

1.05.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Pulmón: El cuadro clínico y la radiografía sugerían un cáncer de pulmón, pero ninguna de las opciones del Eunacom real tenían dicha respuesta. Así es el Eunacom y no se puede reclamar. Para efectos de subirlo a la plataforma, incluimos la opción.

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial**

1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH). El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial**

1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Tumor de Pancoast (tumor del surco pulmonar superior) se ubica en el vértice apical y comprime estructuras vecinas: el plexo braquial inferior (raíces C8, T1 y T2) generando dolor urente irradiado al borde cubital del brazo, y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado, provocando el Síndrome de Claude-Bernard-Horner ipsilateral caracterizado por la tríada clásica de ptosis palpebral, miosis y anhidrosis facial.

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial**

1.05.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH). El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

**Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial**

1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Tiene un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Lo primero es el TAC. Luego será la Bx transbronquial, mediante broncoscopía. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido revisarlas, antes del TAC.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: C**

**Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática**

1.05.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una fibrosis pulmonar.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática**

1.05.1.018, 1.05.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente reúne la clínica prototípica (varón > 60 años, disnea progresiva, crépitos en velcro, acropaquia) y el patrón tomográfico categórico de Neumonía Intersticial Usual (NIU con panalización subpleural bibasal y bronquiectasias por tracción sin hallazgos alternativos), lo que establece el diagnóstico certero de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI). En la FPI los corticoides están formalmente contraindicados por aumentar la mortalidad; el tratamiento indicado son los fármacos antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática**

1.05.1.018, 1.05.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La amiodarona es un antiarrítmico de clase III que se acumula masivamente en el parénquima pulmonar y tejido adiposo, causando toxicidad pulmonar en el 5–10% de los usuarios crónicos. Se manifiesta clínicamente por tos seca, disnea de esfuerzo progresiva e infiltrados intersticiales o alveolares densos bilaterales en la TACAR (debido al alto contenido de yodo del fármaco). El enalapril produce tos seca pero no enfermedad intersticial.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

**Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática**

1.05.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Antecedente de minería orienta a neumoconiosis. La Rx era distinta a la que ahí se muestra.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: C**

**Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación**

1.05.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

**Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación**

1.05.1.015, 1.05.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta un Tromboembolismo Pulmonar de Alto Riesgo (TEP Masivo), definido por la presencia de hipotensión persistente (PAS < 90 mmHg / shock) secundaria a falla aguda del ventrículo derecho por obstrucción masiva del lecho vascular pulmonar. En ausencia de contraindicaciones absolutas mayores (hemorragia activa intracraneal), la terapia farmacológica salvadora de primera línea es la reperfusión inmediata mediante Trombolisis sistémica (Alteplasa 100 mg EV en 2 h). La sobrecarga agresiva de volumen (D) agrava la falla ventricular derecha.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: D**

**Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación**

1.05.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Es un TEP masivo (compromiso hemodinámico), por lo que se estudia con ecocardiograma (para evaluar la disfunción del ventrículo derecho), y no con el angioTAC (de elección en el TEP no masivo).

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

**Hemoptisis y Bronquiectasias**

1.05.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene un cuadro compaGble con bronquiectasias. Se debe revisar el resumen de semiología respiratoria. El diagnóstico se confirma con TAC de tórax de alta resolución.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

**Hemoptisis y Bronquiectasias**

1.05.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho). De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

**Hemoptisis y Bronquiectasias**

1.05.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho). De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

---

## BLOQUE 5 CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Asfixia por inmersión** 1.05.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Asfixia por inmersión" como urgencia clínica (1.05.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Paro cardiorespiratorio** 1.05.2.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorespiratorio" como urgencia clínica (1.05.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: C**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: C**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El efecto Shunt intrapulmonar verdadero se produce cuando la sangre desoxigenada perfunde alvéolos completamente colapsados o inundados de líquido o pus (como ocurre en el SDRA grave, edema pulmonar masivo o atelectasia lobar total). Como el gas inspirado no entra en contacto con la sangre capilar de esas unidades no ventiladas, el aporte de O2 al 100% no logra oxigenar dicha fracción sanguínea, resultando en hipoxemia refractaria al oxígeno.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una IRA Tipo 1 (PaO2 52 mmHg con PaCO2 32 mmHg). La ecuación del gas alveolar arroja PAO2 = 150 - (32 / 0.8) = 110 mmHg. Al restar la PaO2 arterial (110 - 52), el gradiente alvéolo-arterial es de 58 mmHg (valor normal para su edad < 20 mmHg). Un gradiente A-a marcadamente elevado descarta categóricamente una causa extrapulmonar (como hipoventilación o altitud) y confirma la existencia de un daño estructural intrínseco del parénquima pulmonar (como neumonía comunitaria) o de la microvasculatura pulmonar (TEP).

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: B**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una exacerbación aguda de EPOC complicada con acidosis respiratoria hipercápnica descompensada (pH 7.27 y PaCO2 66 mmHg). En este escenario, la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP) es la terapia de soporte ventilatorio de primera línea con recomendación grado 1A: disminuye el trabajo respiratorio, favorece el lavado de CO2, previene la intubación endotraqueal en más del 60% de los pacientes y reduce drásticamente la mortalidad hospitalaria. La intubación orotraqueal se reserva si la VMNI fracasa, si el pH es < 7.20-7.25 refractario o si hay coma profundo.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: E**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Hay evidencia de baja calidad y reciente, muy discutida, que dicen que la ventilación mecánica invasiva tendría mejores resultados en mortalidad y en tiempo de hospitalización, que la oxigenoterapia por mascarilla. Pregunta muy discutible, porque en la vida real, se evaluará primero la respuesta al oxígeno y se irá viendo cuánto necesita para saturar adecuadamente.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: C**

**Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)**

1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

**Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín**

1.05.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente cumple los criterios de Berlín para SDRA: factor de riesgo conocido (sepsis abdominal), tiempo < 7 días, opacidades bilaterales difusas y exclusión de edema cardiogénico. Al tener una relación PaFiO2 de 90 mmHg (con PEEP ≥ 5), se clasifica como SDRA Severo (PaFi ≤ 100). En esta categoría grave, la estrategia con evidencia de máxima categoría para reducir la mortalidad es la ventilación protectora (volumen corriente bajo de 6 mL/kg de peso predicho) y la colocación precoz en decúbito prono durante al menos 16 horas diarias (ensayo PROSEVA).

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

**Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín**

1.05.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Presión Meseta o Plateau (medida realizando una pausa inspiratoria al final de la insuflación) refleja la presión estática que experimentan directamente los alvéolos. La evidencia internacional de ventilación protectora (ARDS Network) ha demostrado que mantener la Presión Plateau en un límite ≤ 30 cmH2O previene la sobredistensión alveolar cíclica y el barotrauma, siendo el parámetro de seguridad alveolar por excelencia. La presión peak (A) incluye la resistencia de la vía aérea y puede elevarse sin necesariamente sobredistender el alvéolo.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

**Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)**

1.05.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severa (>30 eventos por hora; moderada es entre 20 y 30; leve es <20), por lo que requiere C- PAP (se indica en la severa y en la que no responde al tratamiento médico de baja de peso y cambios de posición al dormir). La cirugía podría servir, pero requiere de obstrucción anatómica y además, dada la severidad, el C-PAP igual es de elección.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)**

1.05.1.033 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro clínico describe la presentación prototípica de un Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS): paciente con sobrepeso u obesidad, ronquidos intensos, apneas presenciadas por terceros y marcada hipersomnolencia diurna con puntaje de Epworth anormal (> 10). El examen estándar de referencia para confirmar de manera objetiva el diagnóstico, cuantificar el Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH) y graduar la desaturación de oxígeno es la Polisomnografía nocturna.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)**

1.05.1.033 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En el SAHOS moderado a severo (IAH ≥ 15, y particularmente con IAH ≥ 30), el tratamiento de primera línea no quirúrgico de máxima eficacia es el CPAP nasal nocturno continuo. El CPAP actúa generando una presión positiva hidroneumática constante que mantiene permeable la vía aérea faríngea, aboliendo los ronquidos, las apneas y los microdespertares, normalizando la presión arterial y eliminando la somnolencia diurna. Las benzodiacepinas (E) agravan el colapso.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: B**

1.05.1.024 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo**

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro. Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: B**

1.05.1.024, 1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo**

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro. Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: C**

1.05.1.024, 1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

**Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo**

Las indicaciones estrictas y de consenso para el uso de Oxigenoterapia Hiperbárica (cámara hiperbárica) en intoxicación por monóxido de carbono son: (1) Antecedente de síncope, pérdida de conciencia, coma o convulsiones; (2) Presencia de signos neurológicos focales persistentes; (3) Nivel de Carboxihemoglobina > 25% (o > 15% en mujeres embarazadas); y (4) Evidencia de isquemia miocárdica aguda en el electrocardiograma o acidosis metabólica severa.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: C**

1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo**

La sospecha es una intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de oxígeno es falsamente normal en la oximetría de pulso. Los gases arteriales suelen ser normales, ya que la PaO2 no se altera, sino que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina. Tampoco Genen cianosis (“muertos rosados”). El examen diagnóstico de elección es la medición de carboxihemoglobina. El tratamiento de elección es el oxígeno al 100%. La terapia hiperbárica, además, está indicada si la carboxihemoglobina es mayor a 25% (20% en embarazo) o si hay compromiso de conciencia.

---

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 05 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# NEFROLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Medio Interno

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Nefrología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 05 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS** | | | | | |
| 1.09.1.013 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.1.020 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.1.023 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.1.024 | Urolitiasis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.025 | Uropatía obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.003 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.004 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.2.008 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.2.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.010 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.004 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.4.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.4.016 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.5.003 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| **BLOQUE 2: TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)** | | | | | |
| 1.09.1.007 | Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 05 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.09.1.010 | SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.2 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.020 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.007 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.09.2.008 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25, Q33, Q34, Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.009 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.016 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 3: TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE** | | | | | |
| 1.09.1.001 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.002 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.003 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q52 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.005 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40, Q41 | Tomo 05 · 3.1 (Pág. 31) |
| 1.09.2.006 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 05 · 3.2 (Pág. 35) |
| 1.09.2.008 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.3.009 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q43, Q44 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.016 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q47, Q48, Q49, Q50, Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 4: SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS** | | | | | |
| 1.09.1.006 | Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.09.1.018 | Proteinuria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.021 | Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 05 · 4.3 (Pág. 52) |
| 1.09.1.022 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q62, Q63 | Tomo 05 · 4.1 (Pág. 46) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.2.001 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q61 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.09.2.013 | Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 4.4 (Pág. 54) |
| 1.09.4.016 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q57, Q58, Q59, Q60, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 5: ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS** | | | | | |
| 1.09.1.001 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.004 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q84 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.005 | Bacteriuria asintomática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.008 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q87 | Tomo 05 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.09.1.012 | Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q90 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.014 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.1.015 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 05 · 5.2 (Pág. 67) |
| 1.09.1.016 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q88 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.1.017 | Progresión de la IRC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.019 | Riñón poliquístico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.002 | Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.2.012 | Pre eclampsia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.4.005 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Completo** | | | |
| 1.09.4.016 | **Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Nefrología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.001 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.002 | Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.003 | Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q52 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.004 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q84 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.005 | Bacteriuria asintomática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.006 | Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.09.1.007 | Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 05 · 2.3 (Pág. 24) |
| 1.09.1.008 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.010 | SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.2 (Pág. 22) |
| 1.09.1.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q87 | Tomo 05 · C.22 (Pág. 48) |
| 1.09.1.012 | Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q90 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.013 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.1.014 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.1.015 | Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 05 · 5.2 (Pág. 67) |
| 1.09.1.016 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q88 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.1.017 | Progresión de la IRC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.018 | Proteinuria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.019 | Riñón poliquístico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.020 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17, Q35, Q36 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.1.021 | Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 05 · 4.3 (Pág. 52) |
| 1.09.1.022 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q62, Q63 | Tomo 05 · 4.1 (Pág. 46) |
| 1.09.1.023 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.1.024 | Urolitiasis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.1.025 | Uropatía obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.001 | Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q61 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.09.2.002 | Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q76 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.003 | Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13) |
| 1.09.2.004 | Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11, Q12, Q13 | Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9) |
| 1.09.2.005 | Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40, Q41 | Tomo 05 · 3.1 (Pág. 31) |
| 1.09.2.006 | Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 05 · 3.2 (Pág. 35) |
| 1.09.2.007 | Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q29, Q30 | Tomo 05 · 2.1 (Pág. 18) |
| 1.09.2.008 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q6, Q7, Q8, Q9, Q22, Q23, Q24, Q25, Q33, Q34, Q35, Q36, Q53, Q54 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.2.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.010 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.2.011 | Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71) |
| 1.09.2.012 | Pre eclampsia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8) |
| 1.09.2.013 | Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68, Q69, Q70, Q71 | Tomo 05 · 4.4 (Pág. 54) |
| 1.09.3.004 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.3.009 | Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36, Q43, Q44 | Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26) |
| 1.09.4.005 | Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.09.4.009 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.4.016 | Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q6, Q7, Q8, Q9, Q22, Q23, Q24, Q25, Q38, Q39, Q40, Q41, Q47, Q48, Q49, Q50, Q53, Q54, Q57, Q58, Q59, Q60, Q68, Q69, Q70, Q71, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.09.5.003 | Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15, Q16 | Tomo 05 · 1.3 (Pág. 11) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS

PREGUNTA 1 1.09.1.024

**1. Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis uretral en los últimos años. ¿Cuál es la ateración metabólica más probable en este paciente?**

A) Hipercalciuria
B) Hiperoxaluria
C) Hiperuricosuria
D) Hipocitraturia
E) Hipercistinuria

PREGUNTA 2 1.09.1.025

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía obstructiva · 1.09.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía obstructiva. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 1.09.2.008

**3. Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?**

A) Suero glucosado al 5% ev
B) Suero fisiológico al 0,9% ev
C) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
D) Agua por sonda nasogástrica
E) Sales de rehidratación oral

PREGUNTA 4 1.09.2.009

**4. [URGENCIA: Insuficiencia renal aguda obstructiva · 1.09.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia renal aguda obstructiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 5 1.09.2.010

**5. Un paciente de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, EVA; 9/10, de 6 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes se aprecian 100 glóbulos rojos por campo y 20 glóbulos blancos por campo, en el sedimento de orina. Destaca, además, electrocardiograma con fibrilación auricular y creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:**

A) Quiste renal complicado
B) Urolitiasis
C) Pielonefritis aguda
D) Obstrucción ureteral por coágulos
E) Embolia renal

PREGUNTA 6 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**6.** **Hombre de 72 años con antecedentes de cardiopatía coronaria y uso crónico de furosemida 40 mg/día por insuficiencia cardíaca compensada. Consulta por debilidad y astenia tras 3 días de transgresión dietética y gastroenteritis aguda con vómitos. Al examen: PA 90/60 mmHg, turgencia cutánea disminuida, ortostatismo positivo. Laboratorio: Creatinina 2.9 mg/dL (basal 1.1 mg/dL), BUN 68 mg/dL, Sodio sérico 135 mEq/L, Potasio sérico 3.3 mEq/L, Sodio urinario 38 mEq/L. ¿Cuál es el parámetro más confiable para confirmar si la falla renal es de origen prerrenal en este paciente?**

A) Fracción excretada de sodio (FeNa)
B) Fracción excretada de urea (FeUrea)
C) Sedimento urinario en fresco
D) Resonancia magnética renal con contraste
E) Prueba de furosemida intravenosa en bolo

PREGUNTA 7 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**7.** **Mujer de 64 años ingresa a la Unidad de Paciente Crítico por shock séptico de foco abdominal. A las 24 horas de evolución en ventilación mecánica y noradrenalina, la diuresis acumulada en las últimas 8 horas es de 15 mL/hora (peso 60 kg). Exámenes muestran aumento de creatinina sérica desde 0.9 mg/dL al ingreso hasta 2.8 mg/dL hoy. Sedimento urinario: abundantes cilindros granulosos pigmentados pardos y células epiteliales tubulares aisladas. FeNa: 3.2%. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario de la falla renal?**

A) Hipoperfusión renal reversible sin daño estructural tubular
B) Necrosis tubular aguda isquémica y tóxica con pérdida de polaridad celular
C) Nefritis intersticial aguda alérgica por antibióticos
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa rápidamente progresiva
E) Microangiopatía trombótica con anemia hemolítica microangiopática

PREGUNTA 8 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**8.** **Hombre de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, cólico, de 12 horas de evolución, asociado a anuria absoluta en las últimas 6 horas. Tiene antecedente de hiperplasia prostática benigna y nefrectomía izquierda hace 10 años por trauma. Al examen físico: abdomen blando, doloroso a la palpación en fosa ilíaca y flanco derecho, sin signos de peritonismo. Laboratorio: Creatinina 4.8 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria?**

A) Iniciar hemodiálisis de urgencia inmediata por fístula
B) Administrar 2.000 mL de suero fisiológico en bolo para forzar diuresis
C) Solicitar ecografía renal urgente y descompresión de la vía urinaria
D) Indicar tratamiento con ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular
E) Realizar biopsia renal percutánea de urgencia

PREGUNTA 9 1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016

**9.** **Mujer de 58 años, diabética en tratamiento con Metformina, consulta por cefalea y artromialgias para lo cual se automedicó con Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 7 días. Concomitantemente inició Losartán 50 mg/día indicado por su médico general por cifras tensionales limítrofes. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio: Creatinina sérica 3.1 mg/dL (basal de hace 2 semanas 0.9 mg/dL), BUN 58 mg/dL, K 5.4 mEq/L. No presenta edemas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la explicación farmacológica de este cuadro?**

A) Toxicidad tubular directa de la metformina sobre las células del túbulo distal
B) El ibuprofeno inhibe la vasodilatación de la arteriola aferente y el losartán impide la vasoconstricción de la arteriola eferente
C) El losartán produce vasoconstricción de la arteriola aferente y el ibuprofeno vasodilatación eferente
D) Inducción de nefritis lúpica proliferativa difusa por fármacos antihipertensivos
E) Precipitación intraluminal de cristales de metformina en el asa de Henle

PREGUNTA 10 1.09.1.013

**10.** **Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm3, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:**

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Vasculitis de vasos pequeños
C) Injuria renal pre renal
D) Endocarditis infecciosa
E) Nefritis intersticial

PREGUNTA 11 1.09.2.004

**11.** **Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?**

A) Creatininkinasa
B) Proteinuria de 24 horas
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) Clearence de creatinina

PREGUNTA 12 1.09.2.004, 1.09.1.013

**12. Hombre de 28 años ingresa tras colapso durante una maratón en día caluroso. Al ingreso está obnubilado, deshidratado, con mialgias generalizadas severas. Exámenes: Creatinina 4.2 mg/dL, K 6.1 mEq/L, CPK 68.000 U/L. La orina es de color marrón oscuro; la tira reactiva marca 4+ de sangre, pero el sedimento microscópico muestra apenas 0-2 hematíes por campo. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para prevenir mayor daño renal?**

A) Hemodiálisis de urgencia con filtro de alta permeabilidad
B) Hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos
C) Iniciar corticoides en altas dosis por sospecha de miositis autoinmune
D) Administrar furosemida en infusión continua sin aporte de volumen
E) Indicar tratamiento con manitol al 20% en bolo cada 4 horas

PREGUNTA 13 1.09.2.004, 1.09.1.013

**13. Mujer de 70 años con antecedente de artrosis y dispepsia en tratamiento con Omeprazol y Naproxeno. Consulta por astenia y náuseas. Laboratorio muestra elevación de creatinina sérica a 3.2 mg/dL (basal de hace 2 meses: 0.9 mg/dL). El sedimento urinario muestra 25 leucocitos por campo, cilindros leucocitarios y eosinófilos en orina (tinción de Hansel positiva). El urocultivo es negativo. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Iniciar ciprofloxacino por sospecha de pielonefritis aguda
B) Suspender de inmediato omeprazol y naproxeno
C) Realizar pielografía ascendente retrógrada
D) Indicar diálisis peritoneal continua
E) Aumentar la dosis de IBP para proteger la mucosa gástrica

PREGUNTA 14 1.09.1.023

**14. Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

PREGUNTA 15 1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003

**15. Hombre de 56 años con diabetes mellitus y nefropatía diabética avanzada consulta en el servicio de urgencias por disnea de reposo y ortopnea progresiva. Al examen: PA 180/100 mmHg, FC 105 lpm, SatO2 86% ambiental. Se auscultan crepitaciones bilaterales difusas hasta los tercios superiores de ambos campos pulmonares. Se administran 120 mg de furosemida IV sin lograr diuresis a los 45 minutos. Gases arteriales: pH 7.22, PaO2 55 mmHg, PaCO2 32 mmHg, HCO3 12 mEq/L. Creatinina 6.4 mg/dL, K 5.8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir bolo de 240 mg de furosemida IV
B) Instalar catéter y realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar bicarbonato de sodio al 8.4% en infusión continua
D) Iniciar infusión de nitroglicerina y nebulizaciones con salbutamol
E) Indicar ventilación mecánica no invasiva con CPAP y esperar 24 horas

PREGUNTA 16 1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003

**16. Mujer de 42 años con antecedente de trastorno bipolar en tratamiento crónico con Carbonato de Litio es traída a urgencias por cuadro de compromiso de conciencia, temblor grosero, ataxia y disartria tras deshidratación por diarrea. Los exámenes muestran Creatinina 3.8 mg/dL y una Litemia de 4.8 mEq/L (rango terapéutico 0.6-1.2 mEq/L). ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?**

A) Lavado gástrico con carbón activado seriado
B) Hemodiálisis de urgencia
C) Administración de poliestireno sulfonato de sodio oral
D) Alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio
E) Forzar diuresis osmótica con manitol

PREGUNTA 17 1.09.1.020

**17. Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, 5 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. ¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?**

A) Clortalidona
B) Hidroclorotiazida
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona

PREGUNTA 18 1.09.2.003

**18. Hombre de 52 años con cirrosis hepática Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por hemorragia digestiva alta variceal resuelta con ligadura endoscópica. A las 72 horas presenta oliguria con elevación de creatinina sérica desde 0.8 mg/dL a 2.6 mg/dL. Se suspenden diuréticos y se infunde albúmina humana al 20% a dosis de 1 g/kg/día durante 48 horas consecutivas, manteniéndose la creatinina en 2.5 mg/dL. Sedimento urinario: 2-3 leucocitos por campo, sin cilindros ni proteinuria. Sodio urinario: 6 mEq/L. Presión arterial: 100/60 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Hemodiálisis trisemanal ambulatoria
B) Terlipresina intravenosa asociada a albúmina
C) Infusión de dopamina a dosis renales vasodilatadoras (2 mcg/kg/min)
D) Bolo de furosemida de 120 mg IV
E) Paracentesis evacuadora total de 8 litros sin reposición

## BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS)

PREGUNTA 19 1.09.2.007

**19. Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome carcinoide
D) Accidente vascular encefálico
E) Hipercalcemia

PREGUNTA 20 1.09.2.007

**20. Hombre 60 años con inicio hace 3 semanas de carbamazepina, comienza con náuseas, malestar gástrico, confusión hace 2 días, alteración electrolítica:**

A) Hiponatremia
B) HIPOCALCEMIA???. Era hiponatremia inducida por carbamazepina. - además la clínica (compromiso SNC) orientaba a disnatremia, no tenía nada de discalcemia/diskalemia.
C) Hipokalemia
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 21 1.09.2.007

**21. En el enfrentamiento clínico sistemático de Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 22 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**22. Hombre de 60 años con diagnóstico reciente de neuralgia del trigémino en tratamiento con Carbamazepina desde hace 3 semanas. Consulta por astenia, mareos, náuseas y confusión progresiva de 48 horas de evolución. Al examen físico: orientado en persona pero desorientado en tiempo y espacio, PA 125/75 mmHg, FC 74 lpm, hidratado, sin edemas periféricos ni focalidad neurológica. Exámenes de laboratorio: Glicemia 92 mg/dL, Sodio sérico 118 mEq/L, Potasio 4.2 mEq/L, Creatinina 0.7 mg/dL, Sodio urinario 52 mEq/L, Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y el diagnóstico etiológico más probable?**

A) Hiponatremia euvolémica secundaria a SIADH inducido por carbamazepina
B) Hiponatremia hipovolémica por pérdida renal de sal
C) Pseudohiponatremia por hipertrigliceridemia farmacológica
D) Diabetes insípida central neurogénica
E) Insuficiencia suprarrenal primaria inducida por fármacos

PREGUNTA 23 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**23. Mujer de 70 años con antecedente de depresión en tratamiento con sertralina ingresa a urgencias en coma no reactivo tras presentar dos convulsiones tónico-clónicas generalizadas en su domicilio. Laboratorio de urgencia: Glicemia 105 mg/dL, Sodio plasmático 108 mEq/L, Potasio 3.9 mEq/L, Osmolaridad plasmática 225 mOsm/kg. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Infusión continua de Suero Fisiológico 0.9% a 250 mL/hora
B) Bolo intravenoso de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% en 20 minutos
C) Restricción hídrica estricta a 500 mL/día y control electrolítico en 24 horas
D) Administración de 40 mg de furosemida intravenosa en bolo
E) Infusión rápida de Suero Glucosado al 5% con ampolla de cloruro de potasio

PREGUNTA 24 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**24. Hombre de 54 años con alcoholismo crónico severo y desnutrición ingresa con sodio sérico de 102 mEq/L por hiponatremia hipotónica. Se inicia reposición hidroelectrolítica con solución salina. A las 20 horas de ingreso, el control de laboratorio muestra sodio plasmático en 120 mEq/L (aumento de 18 mEq/L). El paciente evoluciona con disartria, disfagia, tetraparesia espástica y compromiso progresivo de la vigilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta complicación?**

A) Hematoma subdural crónico reagudizado
B) Encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina
C) Síndrome de desmielinización osmótica (mielinolisis pontina central)
D) Accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media
E) Delirium tremens por deprivación alcohólica aguda

PREGUNTA 25 1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016

**25. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos tiazídicos (ej. hidroclorotiazida, clortalidona) producen hiponatremia con mayor frecuencia y severidad que los diuréticos de asa (ej. furosemida)?**

A) Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal bloqueando la excreción de agua libre sin interferir con la médula hiperosmolar
B) Las tiazidas destruyen directamente el gradiente medular de concentración en el asa de Henle
C) Las tiazidas inhiben la síntesis central de hormona antidiurética a nivel supraóptico
D) La furosemida produce mayor pérdida de sodio urinario que las tiazidas por miligramo de fármaco
E) Las tiazidas estimulan de manera directa a los osmorreceptores hipotalámicos induciendo sed patológica

PREGUNTA 26 1.09.1.010

**26. Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A) Uso del enalapril
B) Reacción secundaria al citalopram
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Hipotiroidismo descompensado

PREGUNTA 27 1.09.1.010

**27. Paciente mujer joven sodio bajo osmolaridad sanguínea baja, sodio urinario sobre 100, osmolaridad urinaria 520 (VN 50-1200), VEC normal a. SIADH b. Uso de diuréticos (creo que era esta, pues el SIADH debería tener osmolaridad urinaria alta, que alguien confirme pls)**

C) Insuficiencia suprarrenal
D) Hipotiroidismo
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

PREGUNTA 28 1.09.1.010

**28. En el enfrentamiento clínico sistemático de SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40 mEq/L.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 29 1.09.1.010, 1.09.2.007

**29. Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y depresión mayor tratada con Enalapril y Citalopram consulta para chequeo de rutina. Está completamente asintomática. En sus exámenes destaca: Sodio sérico 127 mEq/L, Potasio 4.1 mEq/L, Creatinina 0.9 mg/dL, Glicemia 88 mg/dL, Osmolaridad plasmática 262 mOsm/kg, Sodio urinario 60 mEq/L y Osmolaridad urinaria 520 mOsm/kg. Al examen físico no presenta edemas ni ortostatismo, signos vitales normales. Pruebas tiroideas y cortisol matinal normales. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A) Efecto adverso del Enalapril por disminución de aldosterona
B) Secreción inadecuada de ADH (SIADH) secundaria a Citalopram
C) Insuficiencia suprarrenal primaria oculta
D) Pérdida renal de sodio por tubulopatía crónica
E) Hipotiroidismo primario descompensado

PREGUNTA 30 1.09.1.010, 1.09.2.007

**30.** **Hombre de 72 años con tabaquismo severo consulta por tos crónica, baja de peso y desorientación fluctuante en la última semana. Al examen físico: adelgazado, vigil, pero desorientado en tiempo, sin focalidad neurológica, PA 130/80 mmHg, hidratado y sin edema. Exámenes: Sodio sérico 121 mEq/L, Sodio urinario 65 mEq/L, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha de bordes espiculados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del trastorno electrolítico?**

A) SIADH por secreción ectópica paraneoplásica de carcinoma pulmonar de células pequeñas
B) Metástasis suprarrenales bilaterales con enfermedad de Addison
C) Síndrome hiperosmolar secundario a neoplasia pulmonar
D) Hiponatremia hipervolémica por insuficiencia cardíaca congestiva
E) Pseudohiponatremia por hiperproteinemia paraneoplásica

PREGUNTA 31 1.09.1.007

**31.** **Paciente usuaria de lamotrigina, ácido valproico y litio, presenta diuresis de 12.600 mL/día, deshidratación e hipernatremia. ¿Cuál es la causa más probable?**

A) Ácido valproico
B) Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)
C) Lamotrigina
D) Polidipsia psicogénica inducida por antipsicóticos
E) Hiperglicemia osmótica

PREGUNTA 32 1.09.1.007

**32.** **Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de aguda. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?**

A) Polidipsia psicógena
B) Consumo de lamotrigina
C) Consumo de litio
D) Consumo de clorpromazina
E) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

PREGUNTA 33 1.09.1.007, 1.09.2.008

**33.** **Mujer de 28 años con antecedente de trastorno afectivo bipolar en tratamiento regular con carbonato de litio consulta por cuadro de varias semanas de polidipsia intensa y poliuria con volúmenes urinarios cercanos a 12 litros al día. Laboratorio muestra: Sodio plasmático 152 mEq/L, Glicemia 84 mg/dL, Osmolaridad urinaria 110 mOsm/kg. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario causante de su poliuria?**

A) Diuresis osmótica inducida por hiperglicemia y glucosuria
B) Resistencia del túbulo colector renal a la acción de la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica)
C) Inhibición de la secreción de vasopresina a nivel hipotalámico por el litio
D) Polidipsia primaria con supresión fisiológica total de la ADH
E) Destrucción necrótica de los túbulos proximales por toxicidad farmacológica

PREGUNTA 34 1.09.1.007, 1.09.2.008

**34.** **Hombre de 22 años sufre traumatismo encéfalo-craneano cerrado con fractura de la base del cráneo en accidente de tránsito. Al tercer día de hospitalización en UCI, presenta bruscamente poliuria de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. Exámenes: Sodio sérico 150 mEq/L, Osmolaridad urinaria 140 mOsm/kg. Se sospecha diabetes insípida de origen central. ¿Cuál es la prueba diagnóstica y terapéutica inicial de elección para confirmar la sospecha?**

A) Prueba de deshidratación o privación de agua durante 12 horas
B) Administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP) y medición seriada de osmolaridad urinaria
C) Resonancia nuclear magnética de silla turca con gadolinio
D) Medición de niveles séricos de vasopresina basal y post estímulo con suero salino hipertónico
E) Biopsia de glándula hipofisiaria guiada por estereotaxia

PREGUNTA 35 1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009

**35.** **Hombre de 75 años con antecedente de insuficiencia renal crónica con TFG estimada de 24 mL/min (Creatinina 2.4 mg/dL) e insuficiencia cardíaca compensada consulta por aumento progresivo de edema en extremidades inferiores hasta rodillas y ortopnea de 2 almohadas. ¿Cuál es el diurético de elección para lograr la descongestión y balance negativo en este paciente?**

A) Hidroclorotiazida
B) Clortalidona
C) Furosemida
D) Indapamida
E) Espironolactona en monoterapia

PREGUNTA 36 1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009

**36.** **Mujer de 78 años con hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida presenta 4 días de diarrea aguda abundante. Al ingreso: soporosa, PA 75/45 mmHg, FC 120 lpm, llene capilar de 4 segundos. Laboratorio de urgencia: Sodio plasmático 156 mEq/L, Potasio 3.2 mEq/L, Creatinina 2.8 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes fluidos intravenosos debe administrarse en primer lugar?**

A) Suero Glucosado al 5% a 500 mL/hora
B) Suero Fisiológico al 0.9% en bolo inicial
C) Solución salina al 3%
D) Agua destilada por vía venosa periférica
E) Solución de bicarbonato 2/3 molar

PREGUNTA 37 1.09.2.005

**37. Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Insulina + glucosa endovenosa
C) Gluconato de calcio endovenoso
D) Kayexalate oral
E) Hemodiálisis de urgencia

PREGUNTA 38 1.09.2.005, 1.09.4.016

**38. Hombre de 68 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva y enfermedad renal crónica estadio 4 consulta por marcada debilidad muscular y palpitaciones lentas. Al examen físico: PA 80/50 mmHg, FC 32 lpm. El monitor muestra ritmo de la unión con QRS ensanchado a 160 ms y ondas T picudas simétricas de gran amplitud. El laboratorio de urgencia informa Potasio plasmático en 8.4 mEq/L. ¿Cuál es la intervención terapéutica inicial prioritaria que debe administrarse de inmediato?**

A) Bicarbonato de sodio 2/3 molar en infusión rápida
B) Insulina cristalina 10 UI asociada a 100 mL de suero glucosado al 30%
C) Gluconato de calcio al 10% intravenoso en 2 a 5 minutos
D) Instalación de marcapasos transitorio transvenoso de urgencia
E) Hemodiálisis inmediata por catéter venoso central

PREGUNTA 39 1.09.2.005, 1.09.4.016

**39. Mujer de 72 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial tratada con Enalapril 20 mg cada 12 horas y Espironolactona 25 mg/día consulta por astenia y malestar general. El ECG revela prolongación del intervalo PR y ondas T altas y acuminadas. El potasio sérico es de 7.2 mEq/L. Se administra una ampolla de gluconato de calcio al 10% IV, revirtiendo transitoriamente los cambios en el ECG. ¿Cuál es el paso siguiente para inducir un rápido desplazamiento del potasio hacia el espacio intracelular?**

A) Resina de intercambio catiónico (sulfonato de poliestireno sódico) por sonda nasogástrica
B) Bolo intravenoso de 10 UI de insulina rápida junto con solución glucosada hipertónica
C) Infusión continua de cloruro de potasio a bajas dosis
D) Bolo de furosemida 120 mg intravenoso
E) Suspender el enalapril y citar a control ambulatorio en 48 horas

PREGUNTA 40 1.09.2.005, 1.09.4.016

**40. Hombre de 27 años con antecedente de insuficiencia renal crónica terminal en programa de hemodiálisis trisemanal no acude a su sesión programada del sábado. El lunes por la mañana consulta en urgencias con marcada debilidad muscular y dificultad para movilizar las extremidades inferiores. Al examen físico se constata tetraparesia flácida simétrica con reflejos osteotendinosos abolidos y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

A) Síndrome de Guillain-Barré
B) Hipokalemia por pérdidas digestivas ocultas
C) Hiperkalemia grave por omisión de terapia de reemplazo renal
D) Accidente cerebrovascular isquémico de tronco encefálico
E) Crisis miasténica autoinmune

PREGUNTA 41 1.09.2.005, 1.09.4.016

**41. Un médico evalúa a un paciente asintomático de 45 años cuyos exámenes de rutina en sangre venosa periférica informan un potasio plasmático de 6.8 mEq/L. El paciente no presenta antecedentes mórbidos, el examen físico es normal y el electrocardiograma de 12 derivaciones es estrictamente normal sin ondas T picudas ni ensanchamiento de complejos. El hemograma muestra plaquetas de 750.000/uL y glóbulos blancos normales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Indicar hemodiálisis de urgencia inmediata
B) Administrar 10 mL de gluconato de calcio al 10% IV
C) Sospechar pseudohiperkalemia y repetir la toma de muestra venosa sin torniquete
D) Administrar sulfonato de poliestireno sódico oral cada 6 horas
E) Iniciar infusión continua de bicarbonato de sodio isotónico

PREGUNTA 42 1.09.2.006

**42. Un paciente de 56 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida presenta irregularidad en sus presiones arteriales, por lo que se decide reemplazar el diurético por clortalidona, con buena respuesta. Se solicitan exámenes de control, entre los que destacan creatinina: 1,0 mg/dl, potasemia: 3,3 mEq/L y natremia: 140 mEq/L. La conducta más adecuada es:**

A) Reemplazar el enalapril por losartán
B) Disminuir cloruro de sodio
C) Reemplazar la clortalidona por furosemida
D) Administrar suero fisiológico
E) Disminuir la dosis de enalapril

PREGUNTA 43 1.09.2.006, 1.09.3.009

**43. Hombre de 62 años con antecedente de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular crónica en tratamiento con digoxina y furosemida consulta por náuseas, astenia y mareos. El ECG muestra bradiarritmia con extrasístoles ventriculares frecuentes, aplanamiento de ondas T y ondas U notorias. El potasio plasmático es de 2.6 mEq/L. ¿Cuál es el riesgo farmacológico inmediato más grave de esta alteración electrolítica?**

A) Precipitación de intoxicación digitálica severa con arritmias ventriculares letales
B) Desarrollo de insuficiencia renal aguda prerrenal anúrica
C) Parálisis periódica tirotóxica irreversible
D) Bloqueo auriculoventricular de primer grado benigno autolimitado
E) Aparición de hipocalcemia sintomática aguda

PREGUNTA 44 1.09.2.006, 1.09.3.009

**44.** **Una paciente de 48 años hospitalizada por pancreatitis aguda en resolución presenta debilidad muscular y calambres. Sus exámenes revelan potasio de 2.9 mEq/L. Se prescribe reposición con cloruro de potasio intravenoso por vía venosa periférica. ¿Cuáles son la concentración máxima recomendada en la solución y la velocidad de infusión periférica segura para prevenir flebitis y toxicidad cardíaca?**

A) Concentración máxima de 40 mEq/L y velocidad no superior a 10 a 20 mEq/hora
B) Concentración máxima de 100 mEq/L y velocidad no superior a 40 mEq/hora
C) Concentración máxima de 20 mEq/L y velocidad obligada de 5 mEq/día
D) Concentración máxima de 80 mEq/L administrada en bolo rápido de 5 minutos
E) Concentración de 60 mEq/L exclusivamente diluida en suero glucosado al 10%

PREGUNTA 45 1.09.1.001

**45.** **Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de creatinina estimado de 35 ml/min. Se realiza exámenes de laboratorio que muestran sodio: 138 mEq/L, cloro: 102 mEq/L potasio: 4,8 mEq/L, bicarbonato plasmático: 16 mEq/L y anion gap: 10. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?**

A) Acumulación de ácidos orgánicos
B) Disminución de la producción de bicarbonato
C) Cetosis
D) Acumulación de ácido úrico
E) Intoxicación por medicamentos

PREGUNTA 46 1.09.1.001

**46.** **Un paciente de 82 años, diabético e hipertenso, consulta por malestar general y edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 63x', edema blando bimaleolar +++. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 86 mg/dl, K+: 5,8 mEq/L, Na+: 133 mEq/L, bicarbonato: 15 mmol/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Hemodiálisis
B) Gluconato de calcio
C) Peritoneodiálisis
D) Bicarbonato de sodio
E) Amlodipino

PREGUNTA 47 1.09.1.001, 1.09.4.016

**47.** **Hombre de 66 años con antecedentes de enfermedad renal crónica estadio G3b (filtrado glomerular estimado de 35 mL/min, creatinina basal 1.8 mg/dL) se realiza exámenes de control ambulatorio en policlínico. El perfil bioquímico muestra: Sodio 138 mEq/L, Cloro 104 mEq/L, Potasio 4.8 mEq/L, Bicarbonato sérico 16 mEq/L. El Anion Gap calculado es de 10 mEq/L (rango normal 8–12). ¿Cuál es la causa fisiopatológica más probable de este trastorno ácido-base?**

A) Acumulación desproporcionada de aniones orgánicos no medidos
B) Disminución de la síntesis renal de amonio y retención compensatoria de cloro (anion gap normal)
C) Cetoacidosis por resistencia periférica a la insulina
D) Depósito tisular de ácido úrico por hiperuricemia secundaria
E) Intoxicación medicamentosa inadvertida por AINEs

PREGUNTA 48 1.09.1.001, 1.09.4.016

**48.** **Mujer de 19 años es traída a la urgencia tras ingerir una sustancia desconocida en intento de autolisis. Se encuentra con compromiso de conciencia, taquipneica y con visión borrosa refiere ver "como en una tormenta de nieve". Exámenes: Gases arteriales muestran pH 7.10, HCO3 7 mEq/L, pCO2 18 mmHg. Sodio 140 mEq/L, Cloro 96 mEq/L, Glicemia 90 mg/dL, BUN 14 mg/dL. Osmolaridad plasmática medida por laboratorio: 330 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico toxicológico más probable?**

A) Intoxicación por monóxido de carbono
B) Intoxicación por metanol
C) Intoxicación por paracetamol
D) Sobredosis de benzodiacepinas
E) Intoxicación por insecticidas organofosforados

PREGUNTA 49 1.09.1.001, 1.09.4.016

**49.** **Hombre de 58 años en shock séptico de foco pulmonar ingresa a UCI conectado a ventilación mecánica. Los gases arteriales de control muestran: pH 7.22, HCO3 10 mEq/L. Según la fórmula de Winter, ¿cuál es el valor de pCO2 esperado para considerar que la compensación ventilatoria es apropiada y que no existe un trastorno respiratorio sobreagregado?**

A) 12 a 16 mmHg
B) 21 a 25 mmHg
C) 35 a 45 mmHg
D) 28 a 32 mmHg
E) 40 a 48 mmHg

PREGUNTA 50 1.09.1.001, 1.09.4.016

**50.** **¿Cuál de las siguientes es una indicación precisa y justificada para la administración de bicarbonato de sodio intravenoso en un paciente con acidosis metabólica aguda?**

A) Cetoacidosis diabética con pH de 7.25 y bicarbonato de 14 mEq/L
B) Acidosis metabólica severa con pH menor a 7.10 e inestabilidad hemodinámica
C) Acidosis láctica por shock séptico con pH de 7.20 en paciente normotenso
D) Para corregir de forma rápida el anion gap en insuficiencia renal leve
E) En todo paro cardiorrespiratorio al inicio de las maniobras de RCP

PREGUNTA 51 1.09.1.002

**51. [ATENCIÓN PRIMARIA: Acidosis metabólica · 1.09.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Acidosis metabólica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 52 1.09.1.003

**52. [ATENCIÓN PRIMARIA: Alcalosis metabólica · 1.09.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Alcalosis metabólica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 53 1.09.2.008, 1.09.4.016

**53. Mujer de 42 años ingresa a urgencias con debilidad muscular severa, espasmos carpopedales involuntarios y parestesias periorales tras una semana de vómitos reiterados por gastroparesia. Gases arteriales muestran pH 7.56, HCO3 40 mEq/L, pCO2 46 mmHg. Sodio 136 mEq/L, Cloro 80 mEq/L, Potasio 2.7 mEq/L. Cloro urinario resulta en 6 mEq/L. ¿Cuál es el tratamiento de elección para corregir el trastorno ácido-base?**

A) Infusión de ácido clorhídrico 0.1 N por vía venosa central

B) Administración de Suero Fisiológico al 0.9% con Cloruro de Potasio intravenoso

C) Acetazolamida intravenosa en bolo

D) Infusión continua de Suero Glucosado al 5% con bicarbonato

E) Espironolactona oral a dosis altas

PREGUNTA 54 1.09.2.008, 1.09.4.016

**54. Hombre de 48 años con hipertensión arterial de difícil control refractaria a 3 fármacos en dosis plenas consulta por astenia y calambres. En sus exámenes destaca: PA 175/105 mmHg, Sodio 144 mEq/L, Potasio 2.9 mEq/L, Bicarbonato 34 mEq/L, pH 7.48. El cloro urinario es de 48 mEq/L. No toma diuréticos ni presenta edemas. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?**

A) Hiperaldosteronismo primario (adenoma suprarrenal productor de aldosterona)

B) Vómitos psicógenos subrepticios con deshidratación

C) Síndrome de Bartter del adulto

D) Insuficiencia suprarrenal primaria

E) Nefropatía pierde sal con hipovolemia

## BLOQUE 4 SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS

PREGUNTA 55 1.09.1.018

**55. Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?**

A) Proteinuria funcional

B) Rabdomiolisis

C) Deshidratación

D) Acidosis metabólica

E) Glomerulopatía membranosa

PREGUNTA 56 1.09.1.022

**56. Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Proteinuria 24h: 8 g. Albúmina 2.0 g/dL. Sin hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome nefrótico puro

B) Síndrome nefrítico agudo

C) Glomerulonefritis membranoproliferativa

D) Nefropatía IgA

E) Pielonefritis crónica

PREGUNTA 57 1.09.1.022, 1.09.4.016

**57.** **Hombre de 65 años con síndrome nefrótico en estudio con proteinuria de 24 horas de 6.5 gramos y albúmina sérica de 2.0 g/dL presenta dolor torácico súbito de tipo pleurítico, disnea y taquipnea. Al examen físico: saturación de oxígeno 88% aire ambiental, FC 115 lpm, PA 110/70 mmHg. La auscultación pulmonar no revela estertores patológicos significativos. ¿Cuál es la complicación aguda más probable de su cuadro renal?**

A) Neumonía bacteriana comunitaria por Streptococcus pneumoniae
B) Tromboembolismo pulmonar agudo secundario a pérdida urinaria de antitrombina III
C) Edema agudo de pulmón no cardiogénico por hipoalbuminemia
D) Infarto agudo de miocardio transmural
E) Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco

PREGUNTA 58 1.09.1.022, 1.09.4.016

**58.** **Mujer de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de un mes de evolución de edema bimaleolar progresivo y edema palpebral matinal. Exámenes de laboratorio: Creatinina 0.8 mg/dL, Albúmina sérica 2.4 g/dL, Colesterol total 380 mg/dL. Sedimento de orina: sin hematuria ni leucocituria, presencia de abundantes cuerpos ovales grasos. Proteinuria cuantitativa de 24 horas: 7.2 gramos. Anticuerpos antinucleares (ANA) negativos, C3 y C4 normales. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección para proseguir el estudio de esta paciente?**

A) Iniciar prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día de forma empírica
B) Realizar biopsia renal percutánea
C) Solicitar electroforesis e inmunofijación de proteínas en suero y orina
D) Indicar tratamiento antiproteinúrico exclusivo con losartán y citar a control en 6 meses
E) Ecografía Doppler de arterias y venas renales como único estudio

PREGUNTA 59 1.09.1.022, 1.09.4.016

**59.** **Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Al examen físico se constata edema con fóvea en ambas extremidades inferiores hasta rodillas. Exámenes: Proteinuria de 24 horas: 8.0 gramos. Albúmina plasmática: 2.0 g/dL. Sedimento urinario sin hematíes ni cilindros hemáticos. ¿Cuál es el diagnóstico sindromático más probable?**

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía por depósitos de IgA
E) Pielonefritis crónica con proteinuria tubular

PREGUNTA 60 1.09.1.022, 1.09.4.016

**60.** **¿Cuál de los siguientes hallazgos en el sedimento microscópico de orina analizado bajo luz polarizada es patognomónico de síndrome nefrótico y lipiduria?**

A) Cilindros céreos anchos de bordes mellados
B) Gotas lipídicas y cuerpos ovales grasos con birrefringencia en Cruz de Malta
C) Cilindros hemáticos con hematíes espiculados
D) Cristales de oxalato de calcio en sobre de carta
E) Cilindros leucocitarios con piuria estéril

PREGUNTA 61 1.09.2.001

**61.** **[URGENCIA: Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: · 1.09.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones:. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 62 1.09.1.022

**62.** **Hombre de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2 a 4 hematíes por campo, 5 leucocitos por campo, creatininemia de 1.1 mg/dL y proteinuria cuantitativa de 24 horas de 7.0 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
B) Glomerulonefritis lúpica clase IV
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune
E) Nefropatía membranosa

PREGUNTA 63 1.09.1.022

**63.** **Hombre de 58 años es diagnosticado mediante biopsia renal de nefropatía membranosa idiopática. Sus niveles séricos de anticuerpos anti-PLA2R resultan negativos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica complementaria prioritaria que se debe realizar en este paciente?**

A) Cribado exhaustivo de neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, próstata) y serologías virales (VHB)
B) Mielograma para descartar leucemia mieloide aguda
C) Punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo
D) Ecocardiograma transesofágico en busca de vegetaciones
E) Iniciar hemodiálisis de mantención de inmediato

PREGUNTA 64 1.09.1.021

**64.** **Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardiaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extre- midades inferiores, con signo de la fóvea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilate- rales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-**

A) Prednisona vía oral
B) Furosemida endovenosa
C) Bisoprolol vía oral
D) Captopril vía oral
E) Amoxicilina vía oral

PREGUNTA 65 1.09.1.021

**65.** **Hombre de 21 años consulta por disnea de medianos esfuerzos, cefalea y emisión de orinas color café oscuro de 2 días de evolución. Hace dos semanas cursó amigdalitis pultácea. Al examen físico: PA 180/110 mmHg, FC 75 lpm, edema periorbitario bilateral y crepitaciones inspiratorias bibasales. Sedimento de orina: hematuria dismórfica masiva (90%), acantocitos y cilindros hemáticos, proteinuria de 900 mg/24 horas. C3 plasmático disminuido y C4 normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial prioritaria?**

A) Iniciar prednisona oral a dosis inmunosupresoras
B) Administrar furosemida intravenosa y restricción estricta de sodio
C) Pulsos de ciclofosfamida intravenosa
D) Amoxicilina oral por 14 días como tratamiento del daño glomerular
E) Biopsia renal percutánea urgente antes de cualquier medida

PREGUNTA 66 1.09.1.021

**66.** **Hombre de 24 años consulta por orinas rojizas de inicio el día de hoy, que coinciden con el segundo día de un cuadro catarral agudo con odinofagia, coriza y febrícula. Al examen físico: PA 120/70 mmHg, afebril, sin edemas periféricos. El sedimento urinario muestra hematuria con 80% de eritrocitos dismórficos. Los niveles séricos de C3 y C4 son estrictamente normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía por depósitos de IgA (enfermedad de Berger)
C) Glomerulonefritis lúpica proliferativa difusa
D) Glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I
E) Nefritis tubulointersticial inmunoalérgica

PREGUNTA 67 1.09.2.013

**67.** **Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria, especialmente en el úl8mo 8empo. Al examen Fsico, presenta frecuencia cardíaca 82 la8dos por minuto, presión arterial 176/111 mmHg, edema bimaleolar y disminución del volumen de orina. El examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos 8empos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales, sin otros ruidos. En los exámenes de laboratorio destacan crea8ninemia: 4,34 mg/dL, BUN: 72 mg/dL, sedimento de orina: 10 leucocitos por campo y 60 hema`es por campo, con 10% de acantocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnós8co?**

A) An2cuerpos an2nucleares (ANA)
B) Biopsia renal
C) An2cuerpos an2citoplasma de neutrófilos (ANCA)
D) UroTAC
E) Electroforesis de proteínas en orina

PREGUNTA 68 1.09.2.013, 1.09.4.016

**68.** **Hombre de 71 años presenta malestar general, astenia, mialgias y febrícula desde hace un mes, agregándose hematuria macroscópica y oliguria en los últimos días. Al examen físico: PA 175/110 mmHg, edema bimaleolar. Exámenes muestran creatinina de 4.3 mg/dL (hace 2 meses 1.0 mg/dL), BUN 72 mg/dL y sedimento de orina con abundantes hematíes con 80% de acantocitos y cilindros hemáticos. ¿Qué examen es el más adecuado y concluyente para confirmar el diagnóstico etiológico específico?**

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Biopsia renal percutánea
C) Urotomografía computarizada con contraste
D) Electroforesis de proteínas en orina de 24 horas
E) Cistoscopía diagnóstica con lavado vesical

PREGUNTA 69 1.09.2.013, 1.09.4.016

**69.** **Mujer de 67 años consulta por astenia progresiva, febrícula y edema de miembros inferiores. Al examen: PA 180/110 mmHg, edema con fóvea ++. Exámenes: Creatinina 4.1 mg/dL, BUN 60 mg/dL, sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo con 80% de dismorfia y cilindros hemáticos. Hemograma muestra hemoglobina 11.8 g/dL, leucocitos normales. El panel serológico informa títulos elevados de ANCA positivos y complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Nefropatía diabética avanzada
C) Nefrosis lipoidea a cambios mínimos
D) Vasculitis de vaso pequeño asociada a ANCA
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

PREGUNTA 70 1.09.2.013, 1.09.4.016

**70.** **Hombre de 30 años ingresa a la urgencia con tos productiva con hemoptisis franca, disnea y orinas color café oscuro de una semana de evolución. La radiografía de tórax revela infiltrados alveolares bilaterales difusos en alas de mariposa. Gases arteriales con hipoxemia moderada. Laboratorio: Creatinina 5.2 mg/dL, sedimento con cilindros hemáticos. La inmunofluorescencia de la biopsia renal demuestra depósito lineal continuo de IgG a lo largo de la membrana basal glomerular. ¿Cuál es el tratamiento prioritario combinado de rescate?**

A) Pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida + plasmaféresis
B) Antibioticoterapia con ceftriaxona y claritromicina en monoterapia
C) Prednisona oral a dosis bajas y salbutamol inhalado
D) Anticoagulación plena con heparina no fraccionada
E) Hemodiálisis exclusiva sin inmunosupresión

PREGUNTA 71 1.09.2.013, 1.09.4.016

**71.** **¿Cuál es el factor pronóstico anatomopatológico más crítico para determinar la recuperabilidad de la función renal en un paciente con Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva?**

A) El porcentaje de glomérulos con semilunas fibrosas y atrofia tubular irreversible
B) La presencia de glucosuria en orina completa
C) El valor absoluto del ácido úrico plasmático
D) El grado de proteinuria selectiva en 24 horas
E) El tamaño de los riñones en la radiografía simple de abdomen

PREGUNTA 72 1.09.1.006

**72.** **Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nefropatía lúpica
B) Nefropatía por IgA
C) Vasculitis ANCA positivo
D) Glomerulonefritis postestreptocócica
E) Glomerulopatía por cambios mínimos

## BLOQUE 5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS

PREGUNTA 73 1.09.1.005

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bacteriuria asintomática · 1.09.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bacteriuria asintomática. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.09.1.017

**74.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Progresión de la IRC · 1.09.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Progresión de la IRC. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.09.1.019

**75. [ATENCIÓN PRIMARIA: Riñón poliquístico · 1.09.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Riñón poliquístico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 76 1.09.2.002

**76. [URGENCIA: Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas · 1.09.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 77 1.09.2.012

**77. [URGENCIA: Pre eclampsia · 1.09.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pre eclampsia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 78 1.09.1.008

**78. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hipertensión arterial esencial · 1.09.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hipertensión arterial esencial. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 79 1.09.1.014

**79. Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, indice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Aumentar dosis de metformina

B) Iniciar hidroclorotiazida

C) Iniciar enalapril

D) Suspender metformina e indicar insulina

E) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

PREGUNTA 80 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**80.** **Hombre de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control regular encontrándose asintomático. Al examen físico se pesquisa presión arterial de 138/84 mmHg, sin otros hallazgos patológicos. Sus exámenes de laboratorio revelan: HbA1c 6.9%, Creatinina 0.8 mg/dL, y un Índice Proteinuria/Creatininuria (o RAC) confirmado de 0.3 mg/mg (300 mg/g). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada e indicada para la protección renal de este paciente?**

A) Aumentar la dosis de metformina a 2.550 mg/día
B) Iniciar hidroclorotiazida 25 mg/día
C) Iniciar enalapril en dosis tituladas
D) Suspender metformina e iniciar esquema de insulina
E) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones

PREGUNTA 81 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**81.** **Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran creatinina de 2.1 mg/dL, con una tasa de filtración glomerular estimada de 24 mL/min/1.73m² (confirmada con examen previo de hace 4 meses similar). No presenta síntomas urémicos. De acuerdo a la normativa de Garantías Explícitas en Salud (GES N° 1) en Chile, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el médico tratante?**

A) Notificar caso GES N° 1 de ERC Etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días
B) Instalar catéter venoso central transitorio para hemodiálisis en el servicio de urgencias
C) Citar a nuevo control en atención primaria en un año para reevaluar función renal
D) Iniciar diálisis peritoneal ambulatoria de forma inmediata en el consultorio
E) Indicar restricción hídrica estricta de 500 mL/día y suspender todo tratamiento oral

PREGUNTA 82 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**82.** **Hombre de 68 años con enfermedad renal crónica estadio 4 en programa de prediálisis es programado para confección de fístula arteriovenosa autóloga. ¿Por qué motivo las guías clínicas recomiendan confeccionar la fístula arteriovenosa con al menos 6 meses de anticipación al inicio previsto de la hemodiálisis?**

A) Para permitir el proceso de maduración y arterialización venosa con adecuado flujo y pared engrosada
B) Para prevenir la aparición de calcificaciones metastásicas en la arteria radial
C) Porque la fístula reduce de inmediato la cifra de creatinina sérica a valores normales
D) Para evitar el uso de eritropoyetina humana recombinante en el paciente
E) Para facilitar la reabsorción distal de potasio en las nefronas residuales

PREGUNTA 83 1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016

**83.** **En un paciente hipertenso con enfermedad renal crónica y proteinuria en quien se inicia tratamiento con Losartán 50 mg/día, se constata a las 2 semanas de control un ascenso de la creatinina sérica desde 1.4 mg/dL hasta 1.65 mg/dL (incremento del 18%) y un potasio sérico de 4.8 mEq/L. El paciente se encuentra clínicamente asintomático y con PA de 128/78 mmHg. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?**

A) Mantener el losartán sin cambios y continuar la monitorización periódica
B) Suspender de inmediato el losartán por toxicidad renal irreversible
C) Reducir la dosis a un cuarto de comprimido y administrar furosemida
D) Indicar hemodiálisis de urgencia por deterioro de filtración
E) Reemplazar el losartán por un AINE a dosis antiinflamatorias

PREGUNTA 84 1.09.1.004

**84.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Anemia en nefrópata · 1.09.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Anemia en nefrópata. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 85 1.09.1.015

**85.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
B) Niveles de T4 libre
C) Calciuria de 24 horas
D) Magnesemia
E) Bicarbonato plasmático

PREGUNTA 86 1.09.1.009

**86. Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. El diagnóstico más probable es:**

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Hipertensión esencial
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente vascular encefálico

PREGUNTA 87 1.09.1.011

**87. [ATENCIÓN PRIMARIA: Infección urinaria baja (cistitis) · 1.09.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Infección urinaria baja (cistitis). El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 88 1.09.1.016

**88. Mujer con hipoacusia neuro con ITU febril → PNA . Qué ATB dejar: a. Meropenem**

B) Gentamicina
C) Amikacina d. Nitrofurantoína —> aminoglucosidos estarían contraindicados en hipoacusia neurosensorial o no?? si pq son ototoxicos
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

PREGUNTA 89 1.09.2.011

**89. Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por cuadro de fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Al examen físico, tiene fiebre de 38,9°C, frecuencia cardíaca 95x', presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 50 leucocitos por campo y abundantes bacterias, estando pendiente el resultado del urocultivo. Las pruebas de bienestar fetal no muestran alteraciones. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para su manejo?**

A) Ciprofloxacino
B) Nitrofurantoína
C) Amoxicilina más ácido clavulánico
D) Ceftriaxona
E) Ampicilina

PREGUNTA 90 1.09.1.012

**90. [ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia renal crónica · 1.09.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia renal crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 INJURIA RENAL AGUDA (IRA) Y URGENCIAS NEFROLÓGICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A Urolitiasis

1.09.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La hipercalciuria es la alteración más frecuente en Chile (40 a 50% de los pacientes con litiasis). De todos modos esta es una pregunta ridícula e inútil, que no debería hacerse.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A Uropatía obstructiva

1.09.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía obstructiva" (1.09.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipecrloremia, da miedo el suero fisiológico (la evidencia no soporta esta recomendación, pero lo habitual es que se crea que el SF puede agravar la hiponatremia). Debería iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero no aparece en las opciones. Se pregunta el primer suero a administrar y el suero glucosado parece la única opción aceptable, ya que es hipotónico. Sin embargo, también está la afirmación: “se corrige primero la volemia y luego, nos preocupamos de los electrolitos” y en ese caso sería correcto el SF, ya que con él se logrará corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado). Entonces ante la duda, se responde así: ¿Qué pasa si le doy solo suero glucosado?: se muere; y ¿qué pasa si le soy solo suero fisiológico?: tal vez vive. Por tanto, se elige el suero fisiológico.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia renal aguda obstructiva" como urgencia clínica (1.09.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 5 Respuesta: E

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una embolia renal clásica, en contexto de una FA (ritmo irregular). Si no tuviera la FA podría haber sido un cólico renal.

### PREGUNTA 6 Respuesta: B

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En pacientes que reciben diuréticos (como la furosemida de uso crónico en este caso), la fracción excretada de sodio (FeNa) y el sodio urinario pierden confiabilidad diagnóstica debido a la natriuresis inducida farmacológicamente a nivel del asa de Henle, arrojando falsos positivos de NTA (FeNa > 1% o Na urinario > 20 mEq/L a pesar de hipovolemia). En este escenario clínico específico, la Fracción Excretada de Urea (FeUrea) es el índice de elección, ya que el transporte de urea en el túbulo proximal no se ve directamente afectado por los diuréticos de asa: un FeUrea < 35% confirma origen prerrenal con alta sensibilidad y especificidad.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro clínico corresponde a una Necrosis Tubular Aguda (NTA) intrínseca establecida secundaria a shock séptico (isquemia hipóxica prolongada y citotoxicidad mediada por citoquinas proinflamatorias). Los hallazgos confirmatorios son: FeNa marcadamente elevado (> 2%, en este caso 3.2%), oliguria persistente y el sedimento urinario patognomónico con cilindros granulosos oscuros ("muddy brown casts") formados por células tubulares descamadas que se aglutinan en la luz tubular. La respuesta A corresponde a IRA prerrenal pura, descartada por el FeNa > 2% y los cilindros.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente es monorreno funcional (nefrectomía izquierda previa) y presenta dolor cólico agudo con anuria absoluta. La anuria súbita (débito 0 mL) es el sello de la obstrucción completa de la vía urinaria (litiasis o compresión ureteral en riñón único) o catástrofe vascular. La conducta inicial obligatoria es descartar y resolver la causa postrenal mediante ecografía renal de urgencia (o TAC sin contraste) para constatar hidronefrosis, seguida de la descompresión urológica urgente (nefrostomía percutánea o catéter doble J). Infundir 2 litros de suero (B) en un paciente anúrico obstructivo provocará edema agudo pulmonar.

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

**Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca**

1.09.2.010, 1.09.2.008, 1.09.4.009, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Este es el mecanismo clásico de "doble bloqueo hemodinámico" que anula la autorregulación renal: el AINE (Ibuprofeno) bloquea la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras en la arteriola aferente, reduciendo el flujo plasmático que entra al ovillo; paralelamente, el ARA-II (Losartán) bloquea el receptor AT1 de la angiotensina II en la arteriola eferente, impidiendo su vasoconstricción compensatoria. El resultado neto es una caída drástica de la presión hidrostática capilar intraglomerular con colapso de la filtración glomerular, generando una IRA hemodinámica que revierte al suspender ambos fármacos.

**PREGUNTA 10** **Respuesta: E**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una nefritis intersticial clásica, con la eosinofilia característica y la insuficiencia renal, probablemente secundaria al tratamiento farmacológico con la cloxacilina (de base tenía una erisipela).

**PREGUNTA 11** **Respuesta: A**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Parece una rabdomiólisis, que se estudia con CK.

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

1.09.2.004, 1.09.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se trata de una rabdomiólisis por esfuerzo extremo con mioglobinuria masiva y Necrosis Tubular Aguda secundaria. La discordancia clásica del dipstick (tira reactiva que marca sangre 4+ debido a que la ortotolidina reacciona con el grupo hemo de la mioglobina libre) frente a la ausencia de glóbulos rojos en el microscopio certifica la mioglobinuria. El pilar fundamental y urgente del tratamiento es la hidratación intravenosa agresiva con cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico o soluciones balanceadas a 200-300 mL/h) para mantener una diuresis elevada (> 2-3 mL/kg/h) y evitar la precipitación de cilindros de mioglobina y la toxicidad tubular directa.

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

1.09.2.004, 1.09.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)**

El cuadro corresponde a una Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda inmunoalérgica secundaria a fármacos (el omeprazol y los AINEs son dos de los principales causantes). La presencia de piuria estéril (leucocitos en orina con urocultivo negativo), cilindros leucocitarios y eosinofiluria confirma el diagnóstico. La primera y más importante medida terapéutica es suspender inmediatamente todos los fármacos potencialmente alergizantes (omeprazol y naproxeno). La mayoría de los pacientes recupera la función renal solo con esta medida; los corticoides se reservan si no hay mejoría tras una semana.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

1.09.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU). Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

El paciente presenta un Edema Pulmonar Agudo con insuficiencia respiratoria severa refractario a dosis altas de diuréticos de asa en el contexto de una falla renal terminal anúrica. Esto corresponde a la "O" (Overload / Sobrecarga de volumen) de los criterios de hemodiálisis de urgencia (AEIOU). Continuar aumentando dosis de diuréticos en un riñón no respondedor solo retrasa el tratamiento definitivo y aumenta la mortalidad; la ultrafiltración inmediata mediante hemodiálisis es la única medida que remueve el exceso de agua y resuelve el edema alveolar.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

1.09.1.023, 1.09.3.004, 1.09.5.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)**

Se trata de una intoxicación grave por Litio (Litemia > 4.0 mEq/L con neurotoxicidad severa y falla renal aguda). El litio es una molécula pequeña, de bajo peso molecular y baja unión a proteínas plasmáticas, lo que la convierte en una sustancia altamente dializable. Corresponde al criterio "I" (Intoxicaciones dializables: SLIME) de las urgencias dialíticas. El carbón activado (A) no une metales como el litio y no tiene ninguna utilidad.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: C**

1.09.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal**

Prefunta difícil. Tiene un edema por IRC (crea de 2,2) y también por IRC, por lo que la furosemida debería servir. Además, la A, B y D son tiazidas (la indapamida no es una tiazida propiamente tal, pero es cercana), por lo que ninguna es. La E sirve para aumentar la sobrevida en la ICC, pero junto a Enalapril y betabloqueo y en esta pregunta se interroga directamente por el manejo del edema.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

1.09.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal**

El paciente cumple con todos los criterios de Síndrome Hepatorrenal (SHR-IRA): cirrosis con ascitis, deterioro agudo de la función renal, oliguria con sodio urinario muy bajo (< 10 mEq/L), sedimento inactivo y confirmación de refractariedad a la expansión con albúmina intravenosa durante 48 horas. La combinación farmacológica de elección según las guías internacionales (EASL) y nacionales es Terlipresina (análogo sintético de la vasopresina con acción vasoconstrictora esplácnica selectiva) más Albúmina humana IV al 20%, lo que permite recuperar la perfusión renal como puente al trasplante hepático.

---

## BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL SODIO Y DEL AGUA (DISNATREMIAS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética (SIADH): El caso describe un SIADH clásico con hiponatremia severa y compromiso neurológico. La causa en este caso es el cáncer de pulmón, ya que las alteraciones del sistema nervioso central y las alteraciones pulmonares son las causas más frecuentes de SIADH. Por el compromiso neurológico, se debe tratar con suero hipertónico a pasar muy lento, para evitar la mielinolisis pontina. Si hubiese estado bien, se maneja solo con restricción de agua libre.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Hiponatremia aguda grave.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica, la conducta médica prioritaria es: Confirmar siempre hiponatremia hipotónica verdadera: en hiperglicemia, corregir sumando 1.6 a 2.0 mEq/L de Na por cada 100 mg/dL de glicemia sobre 100 mg/dL.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La Carbamazepina es un fármaco anticonvulsivante clásico bien conocido por sensibilizar el túbulo colector renal a la vasopresina y estimular la liberación hipotalámica de ADH, desencadenando un SIADH yatrogénico. El paciente presenta la tríada definitoria de SIADH: (1) hiponatremia hipotónica severa (118 mEq/L), (2) estado de euvolemia clínica (sin deshidratación ni edemas), y (3) orina inapropiadamente concentrada (Osmolaridad urinaria 380 mOsm/kg > 100) con natriuresis persistente (Sodio urinario 52 mEq/L > 40) en presencia de función renal y suprarrenal conservadas. El manejo consiste en suspender la carbamazepina y restringir el consumo de agua libre.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una encefalopatía hiponatrémica aguda severa con riesgo vital inminente por edema cerebral difuso y enclavamiento encefálico manifestado por coma y convulsiones recurrentes. En este contexto crítico, las guías internacionales y los consensos nefrológicos establecen que la medida de rescate de primera línea es la infusión rápida de un bolo de 100 a 150 mL de Suero Salino Hipertónico al 3% (NaCl 3%) administrado en 20 minutos. Este bolo persigue elevar la natremia en 4 a 6 mEq/L rápidamente, lo cual reduce de inmediato el volumen celular cerebral hipertensivo y detiene las convulsiones. El suero fisiológico al 0.9% es isotónico respecto al plasma normal pero puede ser inefectivo o incluso empeorar la natremia en SIADH grave.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: C**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde al Síndrome de Desmielinización Osmótica (clásicamente conocido como Mielinolisis Pontina Central). Ocurre cuando una hiponatremia crónica severa se corrige a una velocidad excesiva (en este caso el sodio subió 18 mEq/L en 20 horas, violando ampliamente el límite de seguridad de 6–8 mEq/L/día para pacientes alcohólicos desnutridos). Al hipertonizarse bruscamente el plasma, las células cerebrales que habían agotado sus osmolitos orgánicos sufren una deshidratación osmótica masiva que lesiona de manera irreversible los oligodendrocitos pontinos, provocando desmielinización. Clínicamente se manifiesta de 2 a 6 días después de la corrección rápida con disartria, disfagia, paresia pseudobulbar, tetraparesia espástica y estado locked-in.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica**

1.09.2.007, 1.09.2.008, 1.09.4.016 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Los diuréticos tiazídicos inhiben el cotransportador Na+/Cl- en el túbulo contorneado distal, el cual es el segmento dilutor cortical de la nefrona. Al bloquear este transportador, impiden la generación normal de orina diluida, forzando la excreción de orina hipertónica rica en sodio y potasio. Crucialmente, las tiazidas NO afectan el asa de Henle, por lo que dejan intacto el intersticio medular hiperosmolar renal, permitiendo que la hormona antidiurética (ADH) siga reabsorbiendo agua libre de forma masiva en el túbulo colector. En cambio, los diuréticos de asa bloquean el cotransportador Na+/K+/2Cl- en el asa gruesa de Henle, disolviendo el gradiente medular e impidiendo que el riñón concentre la orina, lo que genera excreción de agua libre y protege paradójicamente contra la hiponatremia.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene un probable SSIADH (hiponatremia, con sodio urinario alto). El citalopram puede causarlo.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Hiponatremia crónica asintomática.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria, la conducta médica prioritaria es: SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osmu > 100 mOsm/kg) y Nau > 40 mEq/L.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010, 1.09.2.007 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El cuadro cumple los criterios estrictos de SIADH: hiponatremia hipotónica (127 mEq/L), euvolemia clínica (sin ortostatismo ni edema), sodio urinario alto (60 mEq/L > 40) y osmolaridad urinaria concentrada (520 mOsm/kg > 100) con funciones renal, suprarrenal y tiroidea normales. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (como el Citalopram) son una causa farmacológica frecuente y reconocida de SIADH en adultos mayores al estimular la liberación hipotalámica de hormona antidiurética.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

**SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria**

1.09.1.010, 1.09.2.007 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El carcinoma neuroendocrino de células pequeñas del pulmón (microcítico u "oat cell") es la neoplasia maligna que con mayor frecuencia causa síndromes paraneoplásicos endocrinos, destacando la secreción ectópica no regulada de hormona antidiurética (vasopresina). Esto desencadena un SIADH clásico con hiponatremia hipotónica euvolémica grave y retención inapropiada de agua libre.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

1.09.1.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: E**

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

1.09.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Hipernatremia, poliuria.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

1.09.1.007, 1.09.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El uso crónico de sales de litio es la causa adquirida más frecuente de Diabetes Insípida Nefrogénica en la práctica médica y en el examen EUNACOM. El litio penetra a las células principales del túbulo colector renal a través del canal apical de sodio sensible a amilorida (ENaC) e inhibe la adenilil ciclasa y la glucógeno sintetasa kinasa 3-beta (GSK3b), bloqueando la expresión y el tráfico de acuaporinas-2 hacia la membrana apical. Esto vuelve al epitelio tubular impermeable al agua a pesar de niveles plasmáticos normales o elevados de ADH.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

**Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)**

1.09.1.007, 1.09.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En un paciente con hipernatremia ya establecida (Na 150 mEq/L) y poliuria hipotónica en contexto de trauma selar o base de cráneo, la prueba de privación de agua está contraindicada por el riesgo de shock y deshidratación letal. El examen indicado es la administración de una dosis de prueba de Desmopresina (DDAVP, 1 a 2 mcg SC o 10 mcg intranasal). Si la osmolaridad urinaria aumenta en más de un 50% a 100% y el volumen urinario desciende drásticamente, se confirma de forma inmediata la Diabetes Insípida Central por déficit de ADH endógena.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

**Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica**

1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada con TFG < 30 mL/min, los diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida) pierden su potencia farmacológica al no alcanzar concentraciones tubulares luminales suficientes en el túbulo distal. En este rango de falla renal, los diuréticos de asa como la Furosemida son los únicos fármacos de primera línea capaces de inducir una natriuresis potente y efectiva para revertir la sobrecarga hídrica, requiriendo frecuentemente dosis más elevadas para compensar la menor carga filtrada.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

**Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica**

1.09.2.008, 1.09.1.020, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En la medicina de urgencia existe una regla fisiopatológica inquebrantable: "Frente a un paciente en shock hipovolémico, la prioridad inicial absoluta es restaurar el volumen circulante eficaz y la perfusión orgánica con cristaloides isotónicos, independientemente de la cifra de sodio sérico". Administrar suero glucosado al 5% distribuiría el 92% del volumen administrado fuera del lecho vascular, perpetuando el shock, la isquemia renal y coronaria. Una vez estabilizada la presión arterial media (PAM ≥ 65 mmHg) con SF 0.9% o Ringer Lactato, se procederá a calcular el déficit de agua libre y corregir la hipernatremia lentamente con soluciones hipotónicas.

---

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL POTASIO Y EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: C**

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

1.09.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Gluconato de calcio endovenoso

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

En toda hiperkalemia grave acompañada de alteraciones electrocardiográficas (bradicardia extrema, QRS ancho u ondas T picudas), la regla de oro internacional es estabilizar de inmediato la membrana celular de los cardiomiocitos para impedir la fibrilación ventricular o asistolia letal. El fármaco de elección absoluta es el Gluconato de Calcio al 10% intravenoso. Su efecto protector es casi instantáneo (1 a 3 minutos). Las medidas para redistribuir el potasio (insulina con glucosa) o para eliminarlo (hemodiálisis) deben coordinarse de inmediato, pero NUNCA deben anteponerse a la administración del calcio.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

Una vez estabilizada la membrana miocárdica con calcio, la fase terapéutica inmediata es el desplazamiento intracelular rápido ("shifting") del potasio plasmático. La medida más potente y rápida es la infusión de 10 Unidades de Insulina Rápida (regular o cristalina) combinada con glucosa hipertónica (ej. 100 mL de SG al 30% o 250 mL al 10%) para prevenir la hipoglicemia. La insulina estimula la bomba Na+/K+-ATPasa ingresando potasio a las células en 15 a 30 minutos. Las resinas de intercambio catiónico (A) tardan varias horas en hacer efecto y no son apropiadas para el rescate agudo.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

En un paciente con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis que omite su sesión de filtración, la retención de potasio es constante y predecible. Las manifestaciones clínicas clásicas de la hiperkalemia grave combinan dos esferas principales: la electrofisiología cardíaca (bradicardia, bloqueos AV y arritmias) y el sistema neuromuscular (debilidad muscular profunda, astenia, tetraparesia flácida ascendente e hiporreflexia que simula una parálisis periódica o un síndrome de Guillain-Barré). El diagnóstico es hiperkalemia grave y requiere ECG y tratamiento de urgencia inmediatos.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: C**

1.09.2.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana**

La presencia de una hiperkalemia significativa en un paciente clínicamente asintomático, sin factores de riesgo conocidos de falla renal o ingesta de fármacos retenedores de potasio, y con un electrocardiograma completamente normal, orienta con fuerza a una Pseudohiperkalemia. Ésta se produce por la liberación in vitro de potasio intracelular tras la extracción sanguínea, típicamente por hemólisis traumática por torniquete prolongado, o por desgranulación de plaquetas en pacientes con trombocitosis marcada (> 500.000/uL). La conducta adecuada es confirmar el hallazgo mediante una nueva toma de muestra venosa atraumática sin torniquete o gasometría arterial con electrolitos antes de instaurar tratamientos potencialmente dañinos.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

1.09.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 140). Evalúa el manejo clínico de Hipokalemia según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

1.09.2.006, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

La hipokalemia es el principal factor facilitador de la toxicidad e intoxicación por digitálicos (digoxina). El potasio y la digoxina compiten por el mismo sitio de unión en la subunidad alfa extracelular de la bomba Na+/K+-ATPasa del miocito. Cuando existe hipokalemia, la digoxina se une de forma masiva y prolongada a la bomba, intensificando drásticamente su inhibición enzimática y desencadenando arritmias ventriculares graves potencialmente mortales (taquicardia ventricular bidireccional, fibrilación ventricular). Por ello, en pacientes usuarios de digoxina, la kalemia debe mantenerse rigurosamente sobre 4.0 mEq/L.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A**

1.09.2.006, 1.09.3.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio**

Las directrices clínicas estandarizadas de farmacoterapia intravenosa establecen que por vía venosa periférica la concentración de cloruro de potasio (KCl) no debe sobrepasar los 40 mEq por litro de solución (para evitar el dolor intenso, espasmo vascular y flebitis química) y el ritmo de infusión no debe superar los 10 a 20 mEq por hora. Para velocidades o concentraciones mayores se requiere acceso venoso central bajo monitorización continua.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

Acidosis metabólica con anión gap normal: El diagnóstico es acidosis metabólica, ya que el bicarbonato está bajo con un anión gap normal (entre 8 y 12). El anion gap se eleva en las demás opciones, ya que refleja la acumulación de ácidos orgánicos. En este caso, la causa es la misma falla renal.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una arritmia maligna, pero, por lo general, el gluconato de calcio solo está indicado si hay compromiso electrocardiográfico o si el potasio está sobre 7 mEq/L. La acidosis sí se debe tratar con bicarbonato de sodio, ya sea EV o VO, dependiendo del pH (en este caso no lo dan, pero por el nivel de bicarbonato parece candidato a EV). Las diálisis solo se indican si es que tiene un síndrome urémico o una complicación grave y refractaria al tratamiento médico. Como se pregunta la conduta inicial, en conjunto con varios especialistas, asumimos que la respuesta es el gluconato de calcio, para el manejo de la hiperkalemia, pero insistimos en que es una pregunta mala.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

En las etapas intermedias de la Enfermedad Renal Crónica (estadios G3 a G4 con TFG entre 20 y 45 mL/min), la acidosis metabólica característica es típicamente con Anion Gap Normal (hiperclorémica). Esto se debe a que la reducción de la masa de nefronas funcionantes disminuye la amoniagénesis tubular proximal (síntesis de buffer amonio $NH4+$), limitando la excreción neta de protones mientras el riñón reabsorbe cloro para mantener la electroneutralidad. La acidosis con Anion Gap Elevado solo aparece en etapas terminales (G5 o TFG < 15 mL/min) cuando se acumulan fosfatos, sulfatos y uratos.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

La paciente presenta una acidosis metabólica severa con Anion Gap marcadamente elevado: AG = 140 - (96 + 7) = 37 mEq/L. Calculando la osmolaridad plasmática: 2 x 140 + 90/18 + 14/2.8 = 280 + 5 + 5 = 290 mOsm/kg. La Brecha Osmolar (Osmolar Gap) es: 330 - 290 = 40 mOsm/kg (muy superior al valor normal de 10 mOsm/kg), lo que certifica la presencia de un alcohol de bajo peso molecular. La queja de visión borrosa "en tormenta de nieve" con hiperemia de papila óptica es patognomónica de la toxicidad ocular del ácido fórmico, metabolito tóxico del Metanol. Requiere Fomepizol o etanol y hemodiálisis urgente.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

La fórmula de Winter predice la $pCO2$ compensatoria en acidosis metabólica: $pCO2 = 1.5 \times [HCO3] + 8 \pm 2$. Con un bicarbonato de 10 mEq/L: 1.5 x 10 = 15; sumando 8 da 23 mmHg. El rango de compensación respiratoria fisiológica pura es de 21 a 25 mmHg. Si la $pCO2$ fuera mayor a 25 mmHg se diagnosticaría acidosis respiratoria concomitante; si fuera menor a 21 mmHg, alcalosis respiratoria asociada.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

1.09.1.001, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El consenso de las guías internacionales (Surviving Sepsis Campaign, guías KDIGO y ADA) reserva el uso de bicarbonato de sodio intravenoso exclusivamente para situaciones críticas con pH sanguíneo < 7.10 o bicarbonato < 6 a 8 mEq/L refractario, especialmente cuando condiciona inestabilidad hemodinámica o refractariedad a vasopresores. En pH > 7.15 (como en las opciones A y C), el bicarbonato no mejora la supervivencia y conlleva graves riesgos de acidosis intracelular paradójica, hipocalcemia y sobrecarga de volumen.

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia**

1.09.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Acidosis metabólica" (1.09.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: A**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Alcalosis metabólica" (1.09.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una alcalosis metabólica salino-responsiva (sensible a cloro) clásica inducida por vómitos, con cloro urinario suprimido (< 20 mEq/L, en este caso 6 mEq/L), hipocloremia profunda e hipokalemia. El tratamiento de elección consiste en expandir el volumen extracelular y aportar cloro mediante la administración de Suero Fisiológico al 0.9% suplementado con Cloruro de Potasio (KCl). El aporte de cloro permite al cotransportador pendrina del túbulo colector intercambiar bicarbonato luminal por cloro, eliminando el bicarbonato en la orina y normalizando el pH de manera rápida y segura.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos**

1.09.2.008, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La combinación de hipertensión arterial resistente de inicio en adulto joven o medio, hipokalemia espontánea persistente y alcalosis metabólica con Cloro Urinario elevado (> 20 mEq/L, salino-resistente) es el cuadro arquetípico del Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn). La secreción autónoma de aldosterona estimula de forma incesante los canales ENaC y las bombas H+-ATPasa en el túbulo colector cortical, forzando la excreción masiva de potasio y protones mientras retiene sodio y expande el volumen extracelular provocando hipertensión arterial.

## BLOQUE 4 SÍNDROMES GLOMERULARES Y NEFROPATÍAS MÉDICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Proteinuria**

1.09.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es normal la proteinuria con el ejercicio intenso. No tiene clínica de rabdomiolisis

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Proteinuria masiva (>3.5 g/24h) + hipoalbuminemia + edema + sin hematuria = síndrome nefrótico puro. En adulto joven sin causa secundaria, la causa más frecuente es nefropatía por cambios mínimos.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El síndrome nefrótico con hipoalbuminemia severa (< 2.5 g/dL) confiere un estado de hipercoagulabilidad severo debido a la pérdida urinaria selectiva de anticoagulantes endógenos fisiológicos, principalmente la Antitrombina III (AT-III), sumada a la hiperfibrinogenemia reactiva hepática. Esta alteración predispone de forma catastrófica a trombosis venosa profunda, trombosis de la vena renal y tromboembolismo pulmonar (TEP). El dolor pleurítico súbito con disnea e hipoxemia en este paciente traduce un TEP agudo.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En todo paciente adulto que debuta con un síndrome nefrótico primario, la Biopsia Renal Percutánea es la conducta diagnóstica de elección obligatoria e insustituible. A diferencia de los niños, en quienes la gran mayoría padece enfermedad por cambios mínimos y se trata empíricamente con corticoides, en los adultos el espectro histológico es sumamente heterogéneo (membranosa, FSGS, cambios mínimos, amiloidosis) y los tratamientos inmunosupresores específicos difieren radicalmente según el patrón anatomopatológico.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de Síndrome Nefrótico Puro: proteinuria en rango nefrótico masivo (> 3.5 g/24 h), hipoalbuminemia marcada (< 3.0 g/dL) y edema clínico, en ausencia total de elementos inflamatorios nefríticos (sin hematuria dismórfica, sin hipertensión arterial y sin cilindros hemáticos). En adultos jóvenes, las causas primarias más comunes son la nefropatía por cambios mínimos o la glomeruloesclerosis focal y segmentaria.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.1.022, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La lipiduria es una consecuencia directa de la filtración glomerular masiva de lipoproteínas en el síndrome nefrótico. Las células del epitelio tubular proximal endocitan estas grasas y al descamarse se observan como cuerpos ovales grasos en la orina. Al ser examinadas bajo luz microscópica polarizada, los ésteres de colesterol presentan una birrefringencia anisotrópica característica en forma de cruz, conocida clásicamente como la "Cruz de Malta", hallazgo distintivo y confirmatorio de síndrome nefrótico.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas**

1.09.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones:" como urgencia clínica (1.09.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: E**

**Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde a un Síndrome Nefrótico Puro en un adulto mayor de 60 años (proteinuria masiva de 7 g/24 h con sedimento urinario inactivo, sin hematuria glomerular). En este grupo etario, la causa más frecuente es la Nefropatía Membranosa. Todas las demás opciones planteadas (Berger, lupus, GNPE, vasculitis) cursan típicamente con síndrome nefrítico o glomerulonefritis proliferativa con hematuria dismórfica intensa, cilindros hemáticos y deterioro inflamatorio renal agudo.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

1.09.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa**

Aproximadamente un 20 a 25% de las nefropatías membranosas del adulto son secundarias. Cuando los anticuerpos anti-PLA2R son negativos en un adulto mayor de 50 años, la sospecha de una etiología secundaria se eleva sustancialmente, siendo la principal causa el origen paraneoplásico por tumores sólidos ocultos (carcinoma pulmonar, de colon, gástrico o de mama) o infecciones virales crónicas (Hepatitis B). El estudio de extensión tumoral y serológico es un mandato prioritario.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también po- dría ser de utilidad.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

El cuadro corresponde a una Glomerulonefritis Postestreptocócica complicada con sobrecarga de volumen severa y emergencia hipertensiva (PA 180/110 mmHg con crepitaciones pulmonares bibasales por congestión venocapilar). Al tratarse de una enfermedad mediada por inmunocomplejos autolimitada, el objetivo terapéutico inmediato es revertir la expansión del volumen extracelular mediante el uso de diuréticos de asa (furosemida endovenosa) y restricción hidrosalina estricta. El uso de antibióticos no modifica el curso del daño glomerular una vez instalado, y los corticoides no están indicados en las formas típicas de GNPE.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

1.09.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)**

La presencia de macrohematuria glomerular inmediatamente contemporánea o a las 24–48 horas del inicio de una infección respiratoria alta ("hematuria sinfaringítica") en un adulto joven, con presión arterial normal y niveles de complemento sérico C3 y C4 completamente normales, es el sello distintivo indiscutible de la Nefropatía por IgA (Enfermedad de Berger). En la GNPE, la latencia habría sido de 1 a 2 semanas y el C3 estaría descendido.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

1.09.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

Tiene los siguientes diagnósticos: insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico, glomerulonefriGs rápidamente progresiva (GNRP) e hipertensión secundaria. La principal sospecha es una micropoliangeíGs o poliangeíGs microscópica (PAM), que es una vasculiGs grave (alta letalidad sin tratamiento), clásica del adulto mayor. Es ANCA positivo en patrón perinuclear (ANCA-p). Biopsia renal y ANCA aparecen como opciones adecuadas, pero la pregunta específica es el examen adecuado para “confirmar el diagnóstico”, por lo que la respuesta correcta es la biopsia renal (examen de elección para el estudio de las GNRP). Sin embargo, es posible que quien redactó la pregunta haya intentado preguntar los ANCA, evaluando la capacidad de identificar el cuadro clínico. Se trata con corticoides sistémicos más rituximab (más usado hoy) o ciclofosfamida. Las recurrencias se evitan con rituximab.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El paciente presenta una sospecha indudable de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) con falla renal acelerada y síndrome nefrítico grave. La Biopsia Renal Percutánea es el examen de referencia (gold standard) imprescindible y obligatorio, ya que permite documentar la presencia y porcentaje de semilunas epiteliales (> 50% confirma GNRP), evaluar el grado de cronicidad fibrocelular versus celularidad activa, y mediante la inmunofluorescencia catalogar de inmediato el tipo específico (anti-MBG lineal, inmunocomplejos granular o pauciinmune) para normar el tratamiento inmunosupresor de emergencia.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: D**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El cuadro corresponde a una vasculitis necrosante de pequeños vasos asociada a ANCA (como la poliangeítis microscópica o granulomatosis con poliangeítis), que debuta clásicamente en adultos mayores como una glomerulonefritis rápidamente progresiva con síndrome nefrítico e hipertensión secundaria severa. La serología con ANCA positivo y la ausencia de consumo de complemento diferencian con claridad esta entidad de la GN postestreptocócica y del lupus.

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El paciente presenta el cuadro clásico del Síndrome de Goodpasture (Enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular) manifestado como síndrome riñón-pulmón (hemorragia alveolar difusa con hemoptisis e insuficiencia renal rápidamente progresiva por GN extracapilar con semilunas). El depósito lineal de IgG en la membrana basal glomerular es patognomónico. El tratamiento de urgencia vital es la combinación sinérgica de: (1) Plasmaféresis diaria para remover los anticuerpos circulantes anti-MBG; (2) Pulsos de Metilprednisolona IV para yugular la inflamación celular; y (3) Ciclofosfamida para inhibir la síntesis de nuevos anticuerpos.

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

1.09.2.013, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA**

El porcentaje de semilunas epiteliales celulares activas versus semilunas fibrocelulares o fibrosas en la biopsia renal es el determinante pronóstico de recuperabilidad más importante. Las semilunas celulares corresponden a proliferación e inflamación activa potencialmente reversibles con terapia inmunosupresora agresiva. En cambio, las semilunas fibrosas con fibrosis intersticial y atrofia tubular avanzada traducen esclerosis terminal irreversible, con nula respuesta a fármacos citotóxicos y evolución inevitable a diálisis crónica.

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

1.09.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica**

Es un lupus sistémico clásico, con afectación renal.

## BLOQUE 5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR Y NEFROPATÍAS CRÓNICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Bacteriuria asintomática** 1.09.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bacteriuria asintomática" (1.09.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Progresión de la IRC** 1.09.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Progresión de la IRC" (1.09.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A** **Riñón poliquístico** 1.09.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Riñón poliquístico" (1.09.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas**

1.09.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas" como urgencia clínica (1.09.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A** **Pre eclampsia**

1.09.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pre eclampsia" como urgencia clínica (1.09.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hipertensión arterial esencial" (1.09.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: C**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tanto por la PA (mayor a 130/80 dice la guía antigua, sin embargo la nueva lo deja en 140/90), como por la proteinuria positiva (IP/ C mayor a 0,2 es proteinuria). La proteinuria hace que sea 100% segura la opción de darle los IECAS.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: C**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En todo paciente diabético que presenta microalbuminuria o proteinuria confirmada (RAC ≥ 30 mg/g o IPC ≥ 0.2), las guías clínicas ministeriales (MINSAL) e internacionales (ADA / KDIGO) establecen que el fármaco antihipertensivo y nefroprotector de elección obligada es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA, como el Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA-II, como el Losartán). Los IECA vasodilatan la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión hidrostática intraglomerular y frenando la progresión de la nefropatía diabética.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una Enfermedad Renal Crónica confirmada en Etapa 4 (TFG entre 15 y 29 mL/min, en este caso 24 mL/min). En Chile, el Problema de Salud GES N° 1 cubre formalmente la ERC en Etapas 4 y 5. La obligación del médico de atención primaria es notificar el caso al sistema GES y emitir la derivación al especialista Nefrólogo en el nivel secundario, quien tiene un plazo garantizado por ley de no más de 30 días para evaluar a la paciente, optimizar el manejo metabólico, vacunar contra hepatitis B y planificar la confección oportuna del acceso vascular (fístula arteriovenosa) pre-diálisis.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Una fístula arteriovenosa (FAV) autóloga requiere someterse al flujo de alta presión pulsátil arterial para que la vena anastomosada se dilate progresivamente, engruese su capa muscular y endotelial ("arterialización") y alcance un calibre y flujo suficientes (> 500–600 mL/min) que permitan soportar punciones repetidas con agujas de diálisis de grueso calibre. Este proceso biológico de maduración vascular tarda típicamente entre 2 a 6 meses. La confección precoz evita que el paciente deba ingresar a diálisis de urgencia con un catéter venoso central transitorio, el cual se asocia a bacteriemias letales y estenosis venosa central.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)**

1.09.1.014, 1.09.1.001, 1.09.4.005, 1.09.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA-II produce una vasodilatación de la arteriola eferente que alivia la hiperfiltración e hipertensión intraglomerular, lo cual genera de manera hemodinámica esperable una discreta disminución del filtrado glomerular reflejada en una elevación leve de la creatinina sérica. Se considera un efecto fisiológico seguro y tolerable si el aumento de la creatinina sérica es menor al 30% respecto al valor basal y la kalemia se mantiene en niveles seguros (< 5.5 mEq/L). Por tanto, con un ascenso del 18% y potasio normal, la conducta correcta es mantener el fármaco y monitorear.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

**Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis**

1.09.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Anemia en nefrópata" (1.09.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

**Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis**

1.09.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal. Si bien la calciuria de 24 horas permite ver el grado de pérdida de calcio diario, lo más importante será determinar los niveles de vitamina D, ya que tanto la falla renal, como el hiperparatiroidismo mismo disminuyen sus niveles, agravando la osteodistrofia. Al medirla, se puede observar el déficit, de modo de indicar suplementos de vitamina D y, además, permite descartar el déficit primario de vitamina D, como causa del HPP.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: D**

**Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal**

1.09.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una HTA renovascular clásica, tanto por el soplo renal, como por la clínica de hipertensión secundaria (joven, severa),

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

1.09.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Infección urinaria baja (cistitis)" (1.09.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: C**

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

1.09.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 70). Evalúa el manejo clínico de Pielonefritis aguda no complicada según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: D**

**Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto**

1.09.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pielonefritis aguda en el embarazo: El cuadro clínico y el sedimento de orina sugieren pielonefritis aguda. Durante el embarazo, las pielonefritis requieren hospitalización y tratamiento con antibióticos intravenosos, generalmente cefalosporinas. Se recomienda la tercera generación (ceftriaxona), aunque también se pueden usar de primera generación. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo. La nitrofurantoína solo es efectiva para infecciones urinarias bajas. La amoxicilina/ácido clavulánico y la ampicilina no se recomiendan en el tratamiento de infecciones urinarias.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible**

1.09.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia renal crónica" (1.09.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 06 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# DIABETES MELLITUS

## 90 Preguntas de Práctica

Dislipidemias

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Diabetes Mellitus · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES** | | | | | |
| 1.02.1.001 | Desnutrición | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.002 | Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.003 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q6 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.004 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.005 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q8 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.006 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.012 | Obesidad | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.013 | Obesidad mórbida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.014 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.016 | Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.017 | Síndromes carenciales de vitaminas y minerales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.018 | Trastornos de conducta alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 06 · C.24 (Pág. 52) |
| 1.04.1.001 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q11, Q12 | Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.04.1.002 | Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7) |
| **BLOQUE 2: FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS** | | | | | |
| 1.02.1.008 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q30 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.009 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.007 | Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.008 | Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.010 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.2.001 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.002 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| **BLOQUE 3: INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO** | | | | | |
| 1.02.2.006 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49, Q50 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.04.1.004 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q44, Q45 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.005 | Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |
| 1.04.1.009 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |
| 1.04.1.018 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.019 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| **BLOQUE 4: EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS** | | | | | |
| 1.02.1.011 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.001 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.002 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q58 | Tomo 06 · C.31 (Pág. 66) |
| 1.02.2.003 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.004 | Déficit agudo de tiamina | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.007 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.04.1.016 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.017 | Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| **BLOQUE 5: COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS** | | | | | |
| 1.02.1.007 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q74, Q75 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.010 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.015 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.019 | Vasculopatía periférica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 06 · C.42 (Pág. 88) |
| 1.02.2.005 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.04.1.011 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q77, Q78 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.013 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.1.014 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |
| 1.04.1.015 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.1.020 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.021 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77) |
| 1.04.1.022 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Diabetes Mellitus · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 06 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.001 | Desnutrición | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.002 | Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.003 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q6 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.004 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.005 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q8 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.006 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.007 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q74, Q75 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.008 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q30 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.009 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31, Q32, Q33, Q34 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.010 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.011 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.012 | Obesidad | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.013 | Obesidad mórbida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.014 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.015 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.016 | Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.1.017 | Síndromes carenciales de vitaminas y minerales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.1.018 | Trastornos de conducta alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 06 · C.24 (Pág. 52) |
| 1.02.1.019 | Vasculopatía periférica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 06 · C.42 (Pág. 88) |
| 1.02.2.001 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.002 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q58 | Tomo 06 · C.31 (Pág. 66) |
| 1.02.2.003 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.004 | Déficit agudo de tiamina | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.005 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.006 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49, Q50 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.02.2.007 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8) |
| 1.04.1.001 | Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q11, Q12 | Tomo 06 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.04.1.002 | Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.04.1.004 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q44, Q45 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.005 | Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |
| 1.04.1.007 | Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| 1.04.1.008 | Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q19, Q20, Q21, Q22, Q23 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.009 | Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38, Q39 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |
| 1.04.1.010 | Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.1.011 | Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q77, Q78 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.013 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.014 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |
| 1.04.1.015 | Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.1.016 | Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |
| 1.04.1.017 | Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.04.1.018 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44) |
| 1.04.1.019 | Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29) |
| 1.04.1.020 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 02 · 5.5 (Pág. 63) |
| 1.04.1.021 | Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77) |
| 1.04.1.022 | Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79) |
| 1.04.2.001 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |
| 1.04.2.002 | Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28, Q29 | Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

PREGUNTA 1 1.02.1.001

**1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Desnutrición · 1.02.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Desnutrición. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 1.02.1.012

**2. Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar insulina

B) Iniciar dieta y ejercicio

C) Iniciar metformina

D) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa

E) Iniciar metformina más glibenclamida

PREGUNTA 3 1.02.1.013

**3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Obesidad mórbida · 1.02.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Obesidad mórbida. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 1.02.1.017

**4. Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?**

A) Fierro

B) Ácido fólico

C) Cianocobalamina

D) Zinc

E) Tiamina

PREGUNTA 5 1.02.1.018

**5. [ATENCIÓN PRIMARIA: Trastornos de conducta alimentaria · 1.02.1.018] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastornos de conducta alimentaria. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 1.02.1.003

**6. Una mujer cursa un embarazo de 10 semanas y se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 128 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Prediabetes
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Glicemia de ayuno alterado
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Intolerancia a la glucosa oral

PREGUNTA 7 1.02.1.004

**7. Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
B) Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
E) Agregar metformina al tratamiento

PREGUNTA 8 1.02.1.005

**8. Un hombre de 33 años, obeso, consulta por polidipsia y baja de peso de 6 kilogramos, en los últimos dos meses. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes, entre los que destacan glicemia de ayuno de 245 mg/dl y hemoglobina glicosilada: 9,2%. El tratamiento inicial más adecuado es:**

A) Metformina
B) Sitagliptina
C) Insulina
D) Liraglutide
E) Glibenclamida

PREGUNTA 9 1.02.1.006

**9. Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina, requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno eran 130 mg/dL y post-prandiales suben a 280 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A) Iniciar insulina
B) Agregar metformina adicional
C) Pioglitazona
D) Glibenclamida
E) Sitagliptina

PREGUNTA 10 1.02.1.014

**10. DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta:**

A) Mejorar calzado
B) Electromiografia, realizar test de nuevo en unos meses (esta era RX para descartar osteomielitis)
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

PREGUNTA 11 1.04.1.001

**11. Una mujer de 31 años, normopeso, con antecedente de vitiligo, consulta por astenia progresiva y baja de 5 kg en dos meses. Se constatan glicemias de ayuno de 260 mg/dL y 295 mg/dL, con HbA1c de 10.5%. No presenta acidosis metabólica. Se le indicó tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, persistiendo con glicemias sobre 250 mg/dL a las tres semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen que confirmaría la sospecha clínica?**

A) Diabetes mellitus tipo 2 resistente; solicitar curva de tolerancia oral a la glucosa
B) Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA); solicitar anticuerpos anti-GAD65 y péptido C
C) Diabetes tipo MODY; solicitar estudio genético de glucoquinasa
D) Diabetes secundaria a pancreatitis crónica; solicitar elastasa fecal
E) Síndrome de Cushing subclínico; solicitar cortisol libre urinario

PREGUNTA 12 1.04.1.001

**12. Un joven de 20 años, deportista, con IMC de 22 kg/m², se realiza chequeo de rutina encontrándose una glicemia de ayuno de 145 mg/dL, confirmada en 150 mg/dL. Refiere que su padre, su tía paterna y su abuelo paterno son diabéticos diagnosticados antes de los 30 años, ninguno con obesidad y todos tratados eficazmente con glibenclamida oral. Los anticuerpos anti-GAD e IA2 resultan negativos. ¿Cuál es el tipo de diabetes más probable?**

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2 del adulto joven
C) Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)
D) Diabetes tipo LADA
E) Hemocromatosis hereditaria juvenil

PREGUNTA 13 1.04.1.002

**13. Un paciente de 52 años, con sobrepeso (IMC 28 kg/m²), asintomático, se realiza un chequeo médico preventivo que muestra una glicemia de ayuno de 118 mg/dL. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada que se debe seguir a continuación?**

A) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e iniciar metformina
B) Repetir la glicemia de ayuno en dos semanas
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Solicitar una hemoglobina glicosilada aislada
E) Dar de alta al paciente asegurando que se encuentra en un rango completamente normal

PREGUNTA 14 1.04.1.002

**14. Un hombre de 46 años consulta por astenia, visión borrosa, polidipsia intensa y nicturia de tres semanas de evolución. Al examen físico se encuentra hidratado y con signos vitales normales. La glicemia capilar tomada en el box al azar arroja 248 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Solicitar glicemia de ayuno venosa para confirmar el diagnóstico la próxima semana
B) Realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos en ayunas
C) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus de inmediato e iniciar manejo terapéutico
D) Solicitar anticuerpos anti-insulina antes de emitir cualquier diagnóstico
E) Indicar dieta estricta sin fármacos y reevaluar con hemoglucotest seriado en un mes

PREGUNTA 15 1.04.1.002

**15. Una paciente de 60 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico secundario a pielonefritis aguda. En sus exámenes de ingreso destaca una glicemia venosa de 240 mg/dL. La paciente no cuenta con antecedentes médicos conocidos ni controles previos. ¿Cuál es el examen de laboratorio más idóneo para determinar con certeza si la paciente es portadora de diabetes mellitus previa versus una hiperglicemia de estrés transitoria?**

A) Prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 g al tercer día
B) Determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
C) Repetición de glicemia venosa en ayuno a las 48 horas de evolución
D) Medición de insulinemia basal y cálculo del índice HOMA-IR
E) Cetonemia cuantitativa

PREGUNTA 16 1.04.1.002

**16. Un paciente de 48 años asintomático, sin antecedentes mórbidos, presenta en su primer examen de medicina preventiva una glicemia venosa en ayunas de 138 mg/dL. Se repite el examen dos semanas después bajo estricto ayuno de 10 horas, resultando en 115 mg/dL. ¿Cuál es el paso diagnóstico que corresponde realizar ahora?**

A) Descartar diabetes mellitus y prediabetes por haber salido la segunda glicemia bajo 126 mg/dL
B) Confirmar diabetes mellitus tipo 2 por haber tenido una primera glicemia sobre 126 mg/dL
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Iniciar monoterapia con metformina 850 mg al día
E) Repetir la glicemia de ayuno una tercera vez al día siguiente

PREGUNTA 17 1.02.1.002

**17. paciente con diabetes gestacional 28 semanas, con tto metformina pero con cifras elevadas de glicemia, se preguntaba cómo continuar tto**

A) Pioglitazona
B) agregar insulina
C) Glibenclamida
D) Sitagliptina
E) Metformina

PREGUNTA 18 1.02.1.016

**18. Un paciente de 30 años, con IMC: 30 Kg/m2 consulta por hoperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociado a aparición de acrocórdones en plieguen inglinales, cervicales y en las axilar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Cushing
B) Hipotiroidismo
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Resistencia a la insulina

## BLOQUE 2 FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

PREGUNTA 19 1.04.1.008

**19. Un paciente de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas con adecuada adherencia. Acude a control trayendo una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 8.4%. Se encuentra asintomático, con examen físico normal y función renal conservada (creatinina 0.8 mg/dL). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada a seguir?**

A) Suspender metformina e iniciar monoterapia con insulina NPH nocturna
B) Mantener metformina y asociar un segundo fármaco oral como glibenclamida
C) Triplicar la dosis de metformina a 1.700 mg cada 8 horas antes de agregar otro fármaco
D) Indicar solo refuerzo de la dieta y citar a nuevo control en un año
E) Iniciar infusión endovenosa continua de insulina rápida

PREGUNTA 20 1.04.1.008

**20. Un paciente de 48 años consulta por astenia intensa, polidipsia y pérdida involuntaria de 7 kg de peso en el último mes. Se constata glicemia de ayuno de 320 mg/dL y una HbA1c de 11.2%. El examen de orina revela glucosuria masiva con trazas de cetonas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de elección?**

A) Metformina 500 mg una vez al día con escalamiento lento
B) Glibenclamida 5 mg cada 12 horas en monoterapia
C) Insulinoterapia de reemplazo (ej. insulina NPH nocturna) asociada a metformina
D) Dieta hipocalórica exclusiva durante cuatro semanas para reducir la gluco-toxicidad
E) Inhibidor de SGLT2 en monoterapia oral

PREGUNTA 21 1.04.1.008

**21. ¿Cuál es el plazo legal máximo garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 2) para el inicio del tratamiento farmacológico en un paciente con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Chile?**

A) Dentro de las primeras 24 horas desde la confirmación diagnóstica
B) A los 15 días tras la evaluación por especialista
C) A los 30 días posteriores al ingreso al programa cardiovascular
D) A los 45 días contados desde la sospecha clínica
E) A los 90 días con entrega de glucómetro

PREGUNTA 22 1.04.1.008

**22. Un paciente de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución, con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 2 años y fracción de eyección ventricular izquierda del 35% (insuficiencia cardíaca con FEVI reducida), mantiene HbA1c de 8.1% con metformina 1.000 mg cada 12 horas. Su VFG es de 55 mL/min/1.73m². Según las recomendaciones internacionales y guías de práctica clínica, ¿cuál es el segundo fármaco que ha demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en este perfil de paciente?**

A) Glibenclamida
B) Pioglitazona
C) Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2, ej. dapagliflozina o empagliflozina)
D) Sulfato de glucosamina
E) Gliclazida

PREGUNTA 23 1.04.1.008

**23. En el enfrentamiento clínico sistemático de Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 24 1.04.1.007

**24. Un paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica consulta para control. En sus exámenes de laboratorio presenta una creatinina de 2.2 mg/dL y una velocidad de filtración glomerular estimada (VFG) de 24 mL/min/1.73m². Actualmente recibe metformina 850 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la conducta farmacológica que se debe adoptar de inmediato?**

A) Mantener la metformina pero indicar consumo abundante de líquidos
B) Suspender de inmediato la metformina debido al riesgo de acidosis láctica
C) Reducir la dosis de metformina a 850 mg al día y controlar en seis meses
D) Cambiar metformina por glibenclamida en dosis máxima de 10 mg al día
E) Asociar bicarbonato oral y mantener la misma dosis de metformina

PREGUNTA 25 1.04.1.007

**25. Un paciente de 78 años en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas ingresa al servicio de urgencias soporoso, diaforético y con glicemia capilar de 32 mg/dL. Se le administra un bolo endovenoso de 40 mL de solución glucosada al 30%, recuperando el estado de alerta con glicemia de control en 125 mg/dL a los 15 minutos. El paciente se siente bien y solicita el alta médica. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Otorgar el alta inmediata recomendándole una colación rica en hidratos de carbono
B) Hospitalizar al paciente para observación y mantención de infusión continua de glucosa durante al menos 24 horas
C) Dar de alta con indicación de reducir la dosis de glibenclamida a la mitad al día siguiente
D) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular y enviar a domicilio en reposo
E) Administrar 100 mg de hidrocortisona endovenosa y dar el alta en dos horas

PREGUNTA 26 1.04.1.007

**26. Un paciente de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de infarto miocárdico hace 1 año presenta una HbA1c de 8.0% a pesar de recibir metformina 1.000 mg cada 12 horas. Se decide agregar dapagliflozina 10 mg al día. ¿Cuál es el efecto secundario de origen infeccioso más frecuentemente asociado al mecanismo de acción de este nuevo fármaco?**

A) Neumonía bacteriana por gérmenes atípicos
B) Infecciones micóticas genitales como vulvovaginitis o balanitis por Candida
C) Gastroenteritis aguda invasora por Campylobacter
D) Pielonefritis enfisematosa fulminante
E) Erisipela recurrente de extremidades inferiores

PREGUNTA 27 1.04.1.007

**27. ¿Cuál de los siguientes fármacos antidiabéticos orales del grupo de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4) posee eliminación predominantemente hepática/biliar y, por lo tanto, NO requiere reducción de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en etapa 4 o 5?**

A) Sitagliptina
B) Vildagliptina
C) Linagliptina
D) Saxagliptina
E) Alogliptina

PREGUNTA 28 1.04.2.001, 1.04.2.002

**28. Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 28 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional, lleva 14 días con régimen dietético fraccionado. En su registro de automonitoreo presenta glicemias de ayuno entre 80 y 90 mg/dL, pero el 30% de sus glicemias a la hora post-almuerzo y post-cena se encuentran entre 150 y 165 mg/dL. La ecografía fetal muestra un feto en percentil 60 de crecimiento. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?**

A) Mantener la dieta exclusiva y reevaluar en un mes
B) Iniciar glibenclamida oral 5 mg antes del almuerzo
C) Iniciar insulina rápida (cristalina o ultrarrápida) antes de las comidas principales
D) Iniciar insulina NPH nocturna a dosis de 0.2 UI/kg a las 22:00 horas
E) Programar interrupción inmediata del embarazo por vía cesárea

PREGUNTA 29 1.04.2.001, 1.04.2.002

**29. ¿Cuál de las siguientes complicaciones fetales o neonatales es la consecuencia directa más frecuente de una diabetes gestacional mal controlada con hiperglicemias maternas postprandiales sostenidas durante el tercer trimestre?**

A) Agenesia sacra o síndrome de regresión caudal
B) Transposición de grandes vasos cardíacos
C) Macrosomía fetal con riesgo de distocia de hombros e hipoglicemia neonatal
D) Oligohidramnios severo con hipoplasia pulmonar
E) Restricción del crecimiento intrauterino simétrico severo

PREGUNTA 30 1.02.1.008

**30. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hipertensión arterial en diabetes tipo 2 · 1.02.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hipertensión arterial en diabetes tipo 2. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 31 1.02.1.009

**31. Una paciente de 67 años, monorrena, es diagnos8cada recientemente de diabetes mellitus 8po 2. Sus exámenes muestran HbA1c de 8,5%, glicemia de ayuno de 132 mg/dL, crea8nina de 4,1 mg/dL, nitrógeno ureico de 68 mg/dL, potasio plasmá8co de 4,2 mEq/L y un clearance de crea8nina es8mado de 12 mL/min. Presenta una relación albuminuria/crea8nuria de 1.100 mg/g. ¿Qué fármaco es el más adecuado para iniciar el tratamiento?**

A) Meeormina
B) Glibenclamida
C) Vildaglip2na
D) Dapagliflozina
E) Semaglu2da

PREGUNTA 32 1.02.1.009

**32. Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y claerence de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Subir la dosis de metformina
B) Agregar glibenclamida
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Tratar con mezcla de insulinas
E) Agregar glipizida al tratamiento

PREGUNTA 33 1.02.1.009

**33. Un paciente de 78 años, diabé8co 8po 2 e hipertenso, sin controles hace 5 años, en tratamiento con enalapril, hidrocloro8azida, amlodipino y me{ormina, Acude a control, con exámenes de laboratorio. Su presión arterial es de 152/96 mmHg y su frecuencia cardíaca de 68 la8dos por minuto. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. Entre sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada: 6%, crea8nina plasmá8ca: 3,8 mg/dL, natremia: 140 mEq/L y potasemia: 4,8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener el tratamiento
B) Suspender la meeormina
C) Suspender el diuré2co
D) Suspender el enalapril
E) Suspender el amlodipino

PREGUNTA 34 1.02.1.009

**34. Un paciente de 45 años, diagnosticado de diabetes hace un mes, se le indicó tratamiento con metformina, la cual suspendió por que le producía diarrea, desde entonces ha estado asintomático. Acude a control con exámenes donde destaca hemoglobina glicosilada de 8,5%, glicemia de ayuno 180mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Indicar Insulina
B) Indicar glibenclamida
C) Indicar rosiglitazona
D) Indicar acarbosa
E) Indicar metformina de acción prolongada

PREGUNTA 35 1.04.1.010

**35.** **Un paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución acude a control de salud. Presenta presiones arteriales promedio de 142/88 mmHg en tomas repetidas. El laboratorio reporta creatinina 0.9 mg/dL y una razón albúmina/creatinina en orina aislada de 180 mg/g (confirmada en dos muestras). ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo de elección más indicado para iniciar tratamiento?**

A) Atenolol 50 mg al día
B) Hidroclorotiazida 25 mg al día
C) Enalapril 10 a 20 mg al día (o Losartán 50 mg al día)
D) Furosemida 40 mg al día
E) Nifedipino de acción corta sublingual según necesidad

PREGUNTA 36 1.04.1.010

**36.** **¿Cuál es el mecanismo hemodinámico intrarrenal primario mediante el cual los fármacos inhibidores de la ECA (como enalapril) disminuyen la proteinuria y enlentecen la progresión de la nefropatía en pacientes diabéticos?**

A) Vasoconstricción refleja de la arteriola eferente glomerular
B) Vasodilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo la presión capilar intraglomerular
C) Vasoconstricción intensa de la arteriola aferente con disminución del flujo plasmático
D) Aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a las macromoléculas
E) Bloqueo directo de la reabsorción tubular de sodio en el asa de Henle

## BLOQUE 3 INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

PREGUNTA 37 1.04.1.004

**37.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 38 1.04.1.004, 1.04.1.009

**38.** **Un paciente de 65 años, diabético tipo 2 de 10 años de evolución, consulta por astenia y baja de peso involuntaria de 6 kg en el último mes, acompañada de poliuria y polidipsia. Actualmente toma metformina 850 mg cada 12 horas y glibenclamida 10 mg cada 12 horas. Sus exámenes demuestran: glicemia de ayunas 282 mg/dL, HbA1c 10.8%, creatinina 1.0 mg/dL y sedimento de orina normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de metformina a 1000 mg cada 8 horas y agregar pioglitazona
B) Suspender glibenclamida e iniciar un inhibidor de DPP-4 (sitagliptina)
C) Iniciar insulina NPH nocturna asociada a metformina
D) Indicar dieta estricta sin carbohidratos y citar a control en 3 meses
E) Cambiar glibenclamida por glimepirida y solicitar prueba de tolerancia a la glucosa oral

PREGUNTA 39 1.04.1.004, 1.04.1.009

**39.** **Una paciente de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con esquema intensificado de insulina consulta por presentar de forma reiterada episodios de sudoración profusa, palpitaciones y temblor entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada. Utiliza insulina NPH a las 20:00 horas (junto con la cena) e insulina cristalina antes de cada comida principal. ¿Cuál es la modificación farmacológica más apropiada para prevenir estos episodios?**

A) Suspender la dosis de insulina cristalina previa a la cena
B) Trasladar la administración de la insulina NPH desde la cena hacia el momento de acostarse (22:30–23:00 hrs)
C) Reducir los carbohidratos complejos de la colación nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH por una dosis matinal única de insulina cristalina
E) Aumentar la dosis de insulina NPH en la cena para superar la hipoglicemia de rebote

PREGUNTA 40 1.04.1.005

**40.** **Un paciente de 20 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en tratamiento con una dosis de insulina NPH matinal y tres dosis de insulina cristalina preprandiales. Se realiza un automonitoreo capilar que demuestra glicemias basales y postprandiales normales, excepto la glicemia medida dos horas después del almuerzo, que de manera constante se encuentra entre 220 y 250 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
B) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo
C) Agregar una dosis de insulina NPH antes del almuerzo
D) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al desayuno
E) Indicar una colación rica en proteínas a media tarde

PREGUNTA 41 1.04.1.005

**41. Un paciente de 18 años, con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina NPH en dos dosis (mañana y noche) e insulina ultra-rápida antes de las comidas, consulta porque sus controles de glicemia matinal en ayunas resultan constantemente elevados, fluctuando entre 220 y 260 mg/dL. No presenta síntomas diurnos. Para precisar la causa de esta alteración y definir el tratamiento, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar en 4 unidades la dosis de insulina NPH nocturna de forma empírica
B) Solicitar una glicemia capilar a las 03:00 de la madrugada
C) Solicitar una hemoglobina glicosilada fraccionada urgente
D) Adelantar la inyección de NPH nocturna a la hora de la cena
E) Cambiar la insulina ultra-rápida por insulina regular pre-cena

PREGUNTA 42 1.04.1.005

**42. Una mujer de 58 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 14 UI al acostarse (22:30 hrs). Trae su control de glicemias capilares de ayuno de los últimos 5 días: 188, 192, 179, 195 y 184 mg/dL. No ha presentado sudoración nocturna, temblores ni pesadillas. La glicemia a las 03:00 AM fue de 145 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste farmacológico más adecuado?**

A) Disminuir la insulina NPH a 10 UI al acostarse
B) Mantener la dosis actual y solicitar curva de tolerancia a la glucosa oral
C) Aumentar la insulina NPH a 18 UI al acostarse
D) Suspender la metformina y cambiar a sulfonilurea matinal
E) Agregar 10 UI de insulina cristalina a las 22:30 hrs

PREGUNTA 43 1.04.1.005

**43. Un paciente de 62 años con DM2 en insulinoterapia basal con NPH 26 UI al acostarse y metformina 850 mg cada 8 horas. Sus glicemias de ayuno se encuentran perfectamente controladas (promedio 102 mg/dL), pero su último control de HbA1c resulta en 8.4%. Su automonitoreo evidencia glicemias post-almuerzo de 230–260 mg/dL, mientras que tras el desayuno y cena son de 130–145 mg/dL. ¿Cuál es la estrategia recomendada por las guías clínicas?**

A) Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna a 34 UI
B) Iniciar esquema Basal-Plus agregando un bolo de insulina prandial antes del almuerzo
C) Fraccionar la insulina NPH en dos tercios en la mañana y un tercio en la noche
D) Agregar glibenclamida 10 mg con el almuerzo
E) Suspender la insulina y reiniciar monoterapia con metformina

PREGUNTA 44 1.04.1.004

**44. Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa al hospital por un cuadro de sepsis de foco urinario, evidenciándose PA 88/55 mmHg, taquicardia de 112 lpm y creatinina plasmática de 2.2 mg/dL. Su glicemia capilar de ingreso es de 260 mg/dL. ¿Cuál es la indicación farmacológica más apropiada para el manejo de su diabetes durante la hospitalización?**

A) Continuar metformina y agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
B) Suspender metformina e indicar insulina cristalina en esquema móvil aislado según hemoglucotest cada 6 horas
C) Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea
D) Mantener metformina reduciendo la dosis a la mitad y administrar bicarbonato profiláctico
E) Indicar hidratación vigorosa sin administrar hipoglucemiantes hasta que la glicemia supere los 300 mg/dL

PREGUNTA 45 1.04.1.004

**45. ¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos adultos no gestantes hospitalizados en servicios de medicina interna?**

A) 70 a 100 mg/dL
B) 80 a 130 mg/dL
C) 140 a 180 mg/dL
D) 180 a 250 mg/dL
E) Menor a 110 mg/dL en todo momento

PREGUNTA 46 1.02.2.006

**46. Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulinodependien- te, en tratamiento con insulina NPH 30U en la mañana y 20 U en la noche. Presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, constatándose un hemoglucotest de 50mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál**

A) Disminuir la insulina NPH matinal
B) Suspender la insulina NPH matinal
C) Disminuir la insulina NPH nocturna
D) Suspender la insulina NPH nocturna
E) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

PREGUNTA 47 1.02.2.006

**47. Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?**

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis

PREGUNTA 48 1.02.2.006

**48. Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida, presenta convulsiones tónico- clónicas subintrantes hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?**

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis (nota: subintrante significa que comienza una nueva crisis, antes de recuperarse por completo de la anterior)

PREGUNTA 49 1.02.2.006

**49. Hombre de 50 años operado de bypass gástrico hace 1 año. Consulta por episodios de sudoración, temblor y mareo 2 horas después de las comidas. Glicemia capilar durante el episodio: 52 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Úlcera marginal
B) Obstrucción de la anastomosis
C) Dumping tardío (hipoglicemia reactiva postprandial)
D) Hipoglicemia por insulinoma
E) Síndrome de asa aferente

PREGUNTA 50 1.02.2.006

**50. Un paciente de 67 años, diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina 1700 mg/día y glibenclamida 20 mg/día, ambos separados en dos dosis diarias consulta por episodios repetidos de mareos, malestar y sudoración, asociado a temblor, que ocurren al final de la mañana o antes de almuerzo. Han coincidido con glicemias capilares de 65 mg/dl. Su IMC es 32 Kg/m2. Su hemoglobina A1c resulta 8,1. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender la glibenclamida
B) Agregar una colación con 25 gramos de hidrato de carbono antes del almuerzo
C) Suspender la glibenclamida
D) Reemplazar la glibenclamida por sitagliptina
E) Reemplazar la metformina por pioglitazona

PREGUNTA 51 1.04.1.018, 1.04.1.019

**51. Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg al día y metformina 850 mg cada 12 horas, es ingresado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia de inicio súbito. Al examen se encuentra soporoso, sudoroso y pálido, con una glicemia capilar de 34 mg/dL. Se administran 40 ml de glucosa al 30% por vía endovenosa, con lo cual el paciente recupera completamente la lucidez en 5 minutos y se encuentra orientado y asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?**

A) Dar de alta con indicación de colación rica en carbohidratos y suspender la dosis de glibenclamida de ese día
B) Hospitalizar al paciente por al menos 24 a 48 horas con infusión continua de glucosa y monitoreo seriado de glicemias
C) Mantener en observación por 2 horas y dar de alta si el hemoglucotest es mayor a 100 mg/dL
D) Administrar 1 mg de glucagón por vía intramuscular y enviar a su domicilio con acompañante
E) Reiniciar inmediatamente la metformina a dosis plena y reducir la glibenclamida a 2.5 mg

PREGUNTA 52 1.04.1.018, 1.04.1.019

**52. Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber presentado 4 episodios de confusión mental, visión borrosa y sudoración profusa en el último mes. Durante uno de los episodios en el hospital, se constata una glicemia venosa de 38 mg/dL. Los exámenes de laboratorio tomados durante la hipoglicemia revelan: insulina plasmática marcadamente elevada, péptido C indetectable y screening negativo para sulfonilureas en orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Insulinoma maligno diseminado
B) Síndrome de dumping tardío posprandial
C) Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)
D) Ingesta accidental o encubierta de glibenclamida
E) Insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune (Enfermedad de Addison)

PREGUNTA 53 1.04.1.018, 1.04.1.019

**53. Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se encuentra lúcido, colaborativo y con capacidad para deglutir normalmente. ¿Cuál es el manejo inicial recomendado según la evidencia y guías clínicas?**

A) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular de inmediato
B) Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos
C) Canalizar una vía venosa periférica e infundir 2 ampollas de glucosa al 30% en bolo
D) Indicar el consumo de un sándwich con mantequilla y carne para retardar la absorción
E) Indicar reposo absoluto y esperar 1 hora para una nueva medición sin ingerir alimentos

PREGUNTA 54 1.04.1.018, 1.04.1.019

**54. Un hombre de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta por mareos y sensación de desmayo ocasional. Refiere que toma enalapril, propranolol y glibenclamida. Durante los últimos controles ha presentado glicemias de 50 a 60 mg/dL sin haber percibido palpitaciones, sudoración ni temblores previos. ¿A qué fármaco de su terapia se atribuye principalmente el enmascaramiento de los síntomas autonómicos de hipoglicemia?**

A) Enalapril
B) Glibenclamida
C) Propranolol
D) A la combinación de enalapril con glibenclamida
E) A ninguno, se debe exclusivamente a neuropatía autonómica diabética avanzada

## BLOQUE 4 EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

PREGUNTA 55 1.02.2.004

**55. Hombre con antecedente de cirugía bariátrica hace 1 año+consumo de OH desde hace 7 meses, deja de asistir a control médico, parte con 1 semana de evolución de ataxia, dificultad de la marcha, visión doble,confusión, somnolencia, cual es la deficiencia:**

A) Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).
B) Vitamina B12
C) Vitamina C
D) Laparotomía exploratoria
E) Cirugía laparoscópica

PREGUNTA 56 1.02.1.011

**56. [ATENCIÓN PRIMARIA: Neuropatía diabética · 1.02.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Neuropatía diabética. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 57 1.02.2.001

**57. [URGENCIA: Acidosis láctica · 1.02.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Acidosis láctica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 58 1.02.2.002

**58. Un joven de 14 años, deportista de alto rendimiento, consulta por un cuadro de poldipsia y poliuria de 3 semanas de evolución, al que hace 7 días se agrega astenia, náuseas y malestar general. Refiere marcada debilidad, después de realizar ejercicio. Se solicitan exámenes, en las que destaca glicemia: 312 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, pH sanguíneo: 7,26, bicarbonato plasmático: 11 mEq/L, exceso de base: -13. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperglicemia secundaria al ejercicio
B) Cetoacidosis diabética
C) Debut de diabetes tipo 2
D) Diabetes insípida descompensada
E) Coma hiperosmolar

PREGUNTA 59 1.02.2.003

**59. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de malestar general y poliuria de dos semanas de evolución, agregándose desorientación y compromiso de conciencia cuan8ta8vo en las úl8mas 48 horas. En su examen, no presenta focalidad neurológica y sus laboratorios revelan glicemia: 950 mg/dL, pH venoso: 7,37, bicarbonato: 18 mEq/L, cetonemia (-), cetonuria (+), sodio plasmá8co: 149 mEq/L y potasio plasmá8co: 5,0 mEq/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Coma hiperosmolar no cetósico
B) Cetoacidosis diabé2ca
C) Síndrome hiperglicémico mixto (hiperosmolar + cetoacidosis)
D) Hipernatremia sintomá2ca
E) Edema cerebral

PREGUNTA 60 1.02.2.007

**60. [URGENCIA: Síndrome hiperosmolar no cetósico · 1.02.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome hiperosmolar no cetósico. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 61 1.04.1.016

**61.** **Un paciente de 17 años consulta en el servicio de urgencias por náuseas, vómitos reiterados y dolor abdominal intenso de 12 horas de evolución. Al examen físico destaca taquipnea profunda de 28 respiraciones por minuto, aliento con olor frutal y mucosas secas. Los exámenes de laboratorio revelan: glicemia 390 mg/dL, pH arterial 7.15, bicarbonato 11 mEq/L, sodio 134 mEq/L, potasio 5.1 mEq/L, cloro 98 mEq/L y glucosuria con cetonuria ++++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Estado hiperglicémico hiperosmolar
B) Cetoacidosis diabética moderada a severa
C) Apendicitis aguda complicada con peritonitis séptica
D) Pancreatitis aguda necrohemorrágica
E) Acidosis láctica asociada a hipovolemia simple

PREGUNTA 62 1.04.1.016

**62.** **Un hombre de 76 años, diabético tipo 2 con secuelas de ACV previo y postrado en cama, es traído al hospital por compromiso de conciencia progresivo de una semana de evolución, asociando fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. Al ingreso se encuentra estuporoso, con signos de deshidratación extrema, PA 85/50 mmHg, FC 110 lpm. Los exámenes de laboratorio demuestran: glicemia 850 mg/dL, pH arterial 7.36, bicarbonato 22 mEq/L, sodio plasmático 152 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, cloro 110 mEq/L y orina con glucosuria masiva sin cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el diagnóstico fundamental?**

A) Cetoacidosis diabética grave
B) Estado hiperglicémico hiperosmolar
C) Accidente cerebrovascular isquémico agudo con hiperglicemia reactiva
D) Shock séptico refractario con acidosis láctica
E) Diabetes insípida nefrogénica

PREGUNTA 63 1.04.1.016

**63.** **¿Cuál de las siguientes fórmulas representa de manera exacta el cálculo de la Osmolaridad Plasmática Efectiva (tonicidad) utilizada para la definición y monitorización del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar?**

A) 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8
B) 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18
C) [Sodio] + [Potasio] - ([Cloro] + [Bicarbonato])
D) 2 * [Sodio] + [Potasio] + [Glicemia] / 10
E) [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8

PREGUNTA 64 1.04.1.016

**64.** **Una paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y empagliflozina consulta en urgencias por astenia severa, disnea de reposo y vómitos tras haber realizado un ayuno prolongado por un procedimiento endoscópico. Al examen físico: PA 110/70 mmHg, FC 98 lpm, polipnea de 24 rpm. Su hemoglucotest de ingreso es de 188 mg/dL. Los gases venosos muestran: pH 7.21, bicarbonato 12 mEq/L, sodio 138 mEq/L, cloro 101 mEq/L, y la cetonemia capilar resulta en 4.2 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico de esta condición?**

A) Intoxicación aguda por metformina con acidosis láctica pura
B) Deshidratación por vómitos con alcalosis metabólica paradójica
C) Cetoacidosis diabética euglicémica inducida por inhibidor de SGLT2
D) Hiperglicemia simple de estrés sin repercusión metabólica
E) Acidosis tubular renal tipo 1 descompensada

PREGUNTA 65 1.04.1.017

**65.** **Un joven de 21 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 es llevado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia progresivo, respiración profunda y ruidosa, y vómitos reiterados. Al ingreso se constata sopor, mucosas secas, PA 85/55 mmHg, FC 122 lpm, hemoglucotest que marca "HI" (> 500 mg/dL) y cetonuria franca. ¿Cuál de las siguientes acciones terapéuticas debe realizarse en PRIMER lugar de forma imperativa?**

A) Administrar un bolo endovenoso de 10 UI de insulina cristalina
B) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio al 2/3 molar
C) Iniciar infusión endovenosa rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1.000 a 1.500 ml en la primera hora)
D) Administrar 20 mEq de cloruro de potasio en bolo endovenoso directo
E) Realizar una punción lumbar para descartar meningoencefalitis infecciosa

PREGUNTA 66 1.04.1.017

**66.** **Un paciente de 25 años en tratamiento por cetoacidosis diabética severa ha recibido 3.500 ml de fluidos y una infusión de insulina cristalina a 0.1 UI/kg/hora durante las últimas 5 horas. Su glicemia plasmática ha descendido progresivamente desde 480 mg/dL hasta 195 mg/dL. Los gases venosos actuales muestran: pH 7.24, bicarbonato 14 mEq/L y Anion Gap de 16 mEq/L (aún elevado). ¿Cuál es la conducta correcta respecto a los fluidos e insulina en este momento?**

A) Suspender completamente la infusión de insulina y pasar a insulina NPH subcutánea
B) Continuar solo con suero fisiológico al 0.9% y duplicar la infusión de insulina a 0.2 UI/kg/h
C) Agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación endovenosa y reducir la infusión de insulina a 0.02–0.05 UI/kg/h
D) Suspender todos los fluidos intravenosos e iniciar tolerancia oral con agua fría
E) Administrar una ampolla de bicarbonato de sodio en bolo para normalizar el pH

PREGUNTA 67 1.04.1.017

**67.** **En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de 140 mEq/L, tras haber completado la reanimación inicial con 1.500 ml de solución salina al 0.9% en la primera hora, ¿cuál es el fluido intravenoso de elección para la fase de mantenimiento?**

A) Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)
B) Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)
C) Suero Glucosado al 10%
D) Ringer Lactato con bicarbonato
E) Agua destilada endovenosa pura sin electrolitos

PREGUNTA 68 1.04.1.017

**68.** **¿Cuál es la velocidad de reducción de la glicemia plasmática considerada óptima y segura durante la fluidoterapia e insulinoterapia en las crisis hiperglicémicas agudas para evitar el edema cerebral?**

A) Más de 150 mg/dL por hora
B) 100 a 140 mg/dL por hora
C) 50 a 75 mg/dL por hora
D) 10 a 20 mg/dL por hora
E) La glicemia debe normalizarse a menos de 100 mg/dL en las primeras 2 horas

PREGUNTA 69 1.04.1.017

**69. Un paciente de 23 años con diabetes tipo 1 ingresa en cetoacidosis diabética severa. Tras la primera hora de infusión de 1.500 ml de suero fisiológico, los exámenes de laboratorio informan: glicemia 430 mg/dL, pH venoso 7.14, bicarbonato 10 mEq/L y potasio plasmático de 3.0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a la administración de insulina y electrolitos?**

A) Iniciar inmediatamente insulina cristalina a 0.1 UI/kg/h y diferir el potasio para cuando la glicemia sea normal
B) Postergar la administración de insulina e infundir cloruro de potasio a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia sea superior a 3.3 mEq/L
C) Administrar un bolo de bicarbonato de sodio y luego iniciar insulina en dosis doble
D) Iniciar insulina NPH subcutánea inmediatamente y restringir la ingesta de potasio
E) Administrar gluconato de calcio endovenoso para antagonizar el potasio

PREGUNTA 70 1.04.1.017

**70. ¿Bajo qué criterio clínico y gasométrico formal está indicada la administración de bicarbonato de sodio endovenoso en un paciente con cetoacidosis diabética según las guías clínicas internacionales y del MINSAL?**

A) Siempre que el bicarbonato sérico sea menor a 15 mEq/L
B) Únicamente si el pH arterial o venoso es menor a 6.90 a pesar de la hidratación inicial
C) Cuando el Anion Gap sea superior a 20 mEq/L
D) En todos los casos con respiración de Kussmaul presente al ingreso
E) En presencia de cetonuria ++++ independiente del valor de pH

PREGUNTA 71 1.04.1.017

**71. Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de control muestran: glicemia 168 mg/dL, pH venoso 7.33, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap 11 mEq/L. Se encuentra lúcido y solicita alimentarse. ¿Cuál es el procedimiento correcto para suspender la bomba de insulina endovenosa y realizar la transición a insulina subcutánea?**

A) Suspender la bomba de infusión endovenosa inmediatamente y esperar 4 horas antes de aplicar la primera dosis subcutánea
B) Inyectar la primera dosis de insulina basal subcutánea y apagar la bomba endovenosa simultáneamente en ese mismo instante
C) Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla
D) Administrar solo insulina ultrarrápida subcutánea cuando la glicemia supere los 250 mg/dL en controles posteriores
E) Mantener la bomba de insulina endovenosa por 48 horas adicionales sin aportar alimentos por boca

PREGUNTA 72 1.04.1.017

**72. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la resolución de una Cetoacidosis Diabética en un adulto?**

A) Glicemia de 220 mg/dL, pH 7.26, bicarbonato 14 mEq/L y cetonuria negativa
B) Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L
C) Glicemia de 140 mg/dL, pH venoso 7.18, bicarbonato 12 mEq/L y glucosuria negativa
D) Glicemia de 95 mg/dL con cetonuria persistente +++ y pH 7.20
E) Glicemia de 250 mg/dL con osmolaridad de 290 mOsm/kg y bicarbonato de 15 mEq/L

## BLOQUE 5 COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

PREGUNTA 73 1.02.1.019

**73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Vasculopatía periférica · 1.02.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vasculopatía periférica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.02.1.007

**74. Diabético con HbA1c en buen rango, LDL 135 mg/dL y TG 330 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Fenofibrato
B) Gemfibrozilo
C) Atorvastatina
D) Omega-3 en dosis farmacológica
E) Ezetimibe

PREGUNTA 75 1.02.1.007

**75. Un paciente de 35 años, en tratamiento con atorvastatina, por hipercolesterolemia y cuyo padre tuvo un infarto a los 40 años, presentó mialgias y artralgias, por lo que decidió suspender el medicamento, sin indicación médica. Se controla con exámenes, entre los que destaca colesterol total: 354 mg/dl, colesterol LDL: 244 mg/dl, colesterol HDL: 70 mg/dl, triglicéridos: 198 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 254 UI/L. El tratamiento más adecuado es:**

A) Colestiramina
B) Dieta estricta
C) Rosuvastatina
D) Ezetimibe
E) Fenofibrato

PREGUNTA 76 1.02.1.010

**76. [ATENCIÓN PRIMARIA: Nefropatía incipiente · 1.02.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Nefropatía incipiente. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 77 1.04.1.011

**77. Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 4 años de evolución en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, normotenso (PA 120/75 mmHg), acude a su control programado. Se le realiza una razón albúmina/creatinina en orina aislada matinal que resulta en 120 mg/g. Se repite el examen dos meses después, confirmándose un valor de 135 mg/g, con cultivo de orina negativo. Su creatinina plasmática es de 0.9 mg/dL. ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada?**

A) Iniciar enalapril o losartán a dosis bajas con titulación progresiva
B) Mantener la terapia actual sin modificaciones dado que el paciente es normotenso
C) Iniciar hidroclorotiazida para disminuir el volumen intravascular
D) Suspender la metformina por toxicidad renal inminente y pasar a insulina
E) Solicitar una biopsia renal percutánea urgente para descartar amiloidosis

PREGUNTA 78 1.04.1.011

**78. ¿A partir de qué momento cronológico debe iniciarse el tamizaje anual de nefropatía diabética mediante la razón albúmina/creatinina en un paciente con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2?**

A) A los 5 años del diagnóstico
B) Al momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad
C) Solo cuando las cifras de hemoglobina glicosilada superen el 8.5%
D) Al momento en que el paciente desarrolle hipertensión arterial concomitante
E) A los 10 años del diagnóstico o a los 65 años de edad

PREGUNTA 79 1.02.1.015

**79. pte diabetico con fondo de ojo alterado tenia buen control metabolico, cual era la medida mas adecuada**

A) Pioglitazona
B) Sitagliptina
C) Insulina NPH
D) Glibenclamida
E) subir metformina??

PREGUNTA 80 1.04.1.013

**80. ¿Cuál es la lesión más precoz que se puede observar mediante la oftalmoscopía en el fondo de ojo de un paciente que está desarrollando una retinopatía diabética?**

A) Exudados duros céreos
B) Microaneurismas retinianos
C) Exudados algodonosos
D) Neovasos papilares
E) Hemorragias en llama extensas

PREGUNTA 81 1.04.1.013

**81. Un paciente de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y controles médicos irregulares, consulta por disminución severa y repentina de la agudeza visual del ojo izquierdo, indolora, instaurada en un par de horas tras levantarse por la mañana. Al examen físico se constata agudeza visual de cuenta dedos en dicho ojo y ausencia del reflejo rojo pupilar, sin signos de inflamación externa. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

A) Oclusión de la arteria central de la retina
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa
D) Neuritis óptica isquémica anterior no arterítica
E) Desprendimiento de retina regmatógeno primario

PREGUNTA 82 1.04.1.014, 1.04.1.015

**82. Un paciente diabético de 61 años presenta una úlcera indolora de 2 cm en la planta del pie derecho, localizada bajo la cabeza del primer metatarsiano, rodeada de un halo de tejido hiperqueratósico. Al examinar la lesión con un estilete metálico estéril de punta roma, se palpa con claridad una superficie ósea dura y resistente en el fondo de la úlcera. Los pulsos arteriales distales son palpables. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Úlcera superficial Wagner 1; indicar curación avanzada ambulatoria con apósito hidrocoloide
B) Úlcera Wagner 3 con osteomielitis subyacente; hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso y evaluación quirúrgica
C) Gangrena seca incipiente Wagner 4; indicar amputación supracondílea de urgencia
D) Úlcera isquémica pura; derivar a cirugía vascular para bypass fémoro-poplíteo ambulatorio
E) Fascitis necrotizante estreptocócica; administrar penicilina intramuscular ambulatoria

PREGUNTA 83 1.04.1.014, 1.04.1.015

**83. ¿Cuál es el instrumento semiológico validado y de primera línea en la atención primaria de salud para el tamizaje anual de la pérdida de la sensibilidad protectora en los pies de los pacientes con diabetes mellitus?**

A) Aguja de punción intradérmica desechable
B) Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos (calibre 5.07)
C) Tubos con agua fría y caliente para sensibilidad térmica
D) Martillo de reflejos de Taylor para reflejo rotuliano
E) Electromiografía de cuatro extremidades obligatoria anual

PREGUNTA 84 1.04.1.014, 1.04.1.015

**84.** **Un paciente de 68 años con DM2 de larga data consulta por una lesión negruzca, seca y momificada que compromete el primer y segundo dedo del pie izquierdo, acompañada de frialdad local, ausencia de pulso pedio y tibial posterior, sin secreción purulenta ni fluctuación. ¿A qué estadio de la clasificación de Wagner corresponde este cuadro clínico?**

A) Grado 2
B) Grado 3
C) Grado 4
D) Grado 5
E) Grado 0

PREGUNTA 85 1.04.1.014, 1.04.1.015

**85.** **Una paciente de 57 años con DM2 consulta por una úlcera de 1.5 cm en la cara lateral del quinto dedo del pie izquierdo tras estrenar un calzado nuevo. Al examen: la úlcera compromete la dermis superficial sin llegar al plano tendinoso ni óseo, no hay exudado purulento ni eritema mayor a 0.5 cm en los bordes. Los pulsos periféricos son normales y no hay dolor. ¿Cuál es el tratamiento local más importante para permitir la resolución y cicatrización de esta lesión?**

A) Aplicación tópica diaria de pomada con corticoides y antibióticos
B) Descarga de la presión y del roce mecánico ("off-loading") asociada a curación avanzada
C) Cauterización química inmediata con nitrato de plata
D) Baños de pies con soluciones antisépticas calientes con povidona yodada
E) Amputación preventiva del quinto radio metatarsiano

PREGUNTA 86 1.04.1.020, 1.04.1.021

**86.** **Un paciente de 60 años, hipertenso, con antecedente de un infarto agudo de miocardio de pared anterior hace 6 meses tratado con angioplastía coronaria, acude a control médico ambulatorio. Su perfil lipídico actual bajo tratamiento con atorvastatina 10 mg al día muestra: Colesterol total 188 mg/dL, c-HDL 45 mg/dL, Triglicéridos 145 mg/dL y c-LDL 112 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir respecto a su terapia hipolipemiante?**

A) Mantener la dosis actual ya que el colesterol total es menor a 200 mg/dL
B) Suspender la estatina y agregar gemfibrozilo 600 mg al día
C) Aumentar la dosis de atorvastatina a 40 u 80 mg al día para alcanzar una meta de c-LDL menor a 70 mg/dL
D) Cambiar atorvastatina por simvastatina 10 mg al día
E) Recomendar únicamente dieta estricta sin grasas saturadas durante 6 meses

PREGUNTA 87 1.04.1.020, 1.04.1.021

**87.** **Una mujer de 55 años que inició tratamiento con atorvastatina 40 mg al día hace 4 semanas por una dislipidemia mixta de alto riesgo consulta por dolores musculares difusos en muslos y hombros, de predominio vespertino. Al examen físico no se aprecian alteraciones articulares ni debilidad motora objetiva. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de laboratorio inicial indispensable para evaluar la seguridad del tratamiento?**

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Creatina Kinasa total (CK)
C) Ácido úrico en sangre
D) Factor reumatoideo cuantitativo
E) Velocidad de eritrosedimentación

PREGUNTA 88 1.02.2.005

**88.** **Un paciente de 45 años, obeso (con IMC:35) y diabético, en tratamiento con metformina y empaglifozina y con antecedente de consumo de 4 cervezas diarias, acude a chequeo. Trae múltiples exámenes, entre los que destaca perfil lipídico con colesterol LDL: 135 mg/dl, colesterol HDL: 27 mg/dl y triglicéridos: 1.000 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente en este momento?**

A) Enviar al servicio de urgencias
B) Iniciar gemfibrozilo 900 mg/día
C) Iniciar rosuvastatina 40 mg/día
D) Iniciar ezetimibe 10 mg/día
E) Iniciar dieta estricta

PREGUNTA 89 1.04.1.022

**89.** **Un hombre de 48 años, asintomático, acude a su control de salud con exámenes preventivos: Colesterol total 250 mg/dL, c-HDL 35 mg/dL, c-LDL no calculable por hipertrigliceridemia y Triglicéridos plasmáticos de 1.280 mg/dL. El examen físico general y abdominal es estrictamente normal. ¿Cuál es el objetivo primordial inmediato y el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Prevenir el infarto agudo de miocardio iniciando atorvastatina 80 mg al día
B) Prevenir la pancreatitis aguda iniciando un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo)
C) Prevenir el accidente cerebrovascular isquémico iniciando aspirina 100 mg al día
D) Prevenir la esteatohepatitis iniciando metformina a dosis plenas
E) Indicar únicamente dieta vegetariana estricta y citar a nuevo control en 6 meses

PREGUNTA 90 1.04.1.022

**90.** **Un hombre de 34 años consulta por la aparición de nódulos indoloros y de consistencia firme en la cara posterior de ambos tobillos a nivel de los tendones de Aquiles. Refiere que su padre falleció súbitamente por un infarto agudo de miocardio a los 41 años. Su perfil lipídico revela: Colesterol total 340 mg/dL, c-HDL 48 mg/dL, Triglicéridos 130 mg/dL y c-LDL de 266 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico genético más probable?**

A) Hipercolesterolemia familiar heterocigota
B) Hipertrigliceridemia familiar aislada
C) Disbetalipoproteinemia familiar tipo III
D) Hiperlipidemia familiar combinada
E) Xantomatosis cerebrotendinosa recesiva

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Desnutrición

1.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Desnutrición" (1.02.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 2 — Respuesta: B — Obesidad

1.02.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene obesidad y resistencia a la insulina (HOMA = 96 x 23 / 405 = 5,5). No tiene ni diabetes, ni intolerancia a la glucosa, ni glicemia alterada de ayuno, así que solo se deja dieta y ejercicio.

### PREGUNTA 3 — Respuesta: A — Obesidad mórbida

1.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Obesidad mórbida" (1.02.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 4 — Respuesta: C

**Síndromes carenciales de vitaminas y minerales**

1.02.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un déficit de B12, tanto por el antecedente de by-pass como por la macrocitosis y plaquetopenia. La ferritina está normal (VN: 15 a 300).

### PREGUNTA 5 — Respuesta: A — Trastornos de conducta alimentaria

1.02.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastornos de conducta alimentaria" (1.02.1.018), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 6 — Respuesta: D

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

1.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Si bien le falta otra glicemia de ayuno mayor o igual a 126, para confirmar el diagnóstico, sobre dicho valor se sospecha una diabetes pregestacional.

### PREGUNTA 7 — Respuesta: B

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

1.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La DM1 se debe tratar con esquema intensificado: idealmente insulina glargina basal, con refuerzos con insulina ultrarrápida. Se acepta también las dos dosis de NPH, con referzos con IC precomidas. Las demás opciones son claramente insuficientes.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

1.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

Tanto por los síntomas de diabetes (baja de peso y polidipsia), como por la HbA1c mayor a 9%, está indicada la insulina.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

1.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

Corticoides causan hiperglicemia postprandial marcada por resistencia a la insulina. La insulina es el tratamiento de elección en este contexto (flexibilidad de ajuste, control rápido). Los hipoglicemiantes orales no dan el control necesario con dosis altas de corticoides.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

1.02.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 93). Evalúa el manejo clínico de Pié diabético y otras infecciones en diabetes según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

1.04.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

El cuadro de debut hiperglicémico severo en una adulta joven sin obesidad, con comorbilidad autoinmune previa (vitiligo) y falla primaria rápida al tratamiento con metformina oral, orienta decididamente a Diabetes LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). El examen de elección para certificar la etiología es la determinación de anticuerpos anti-GAD65 (positivos en más del 80%) y la medición de péptido C plasmático (que evidenciará reserva beta deficiente).

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: C**

1.04.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY**

La presencia de diabetes de inicio precoz (< 25 años) en un paciente delgado sin datos de resistencia a la insulina ni autoinmunidad (anti-GAD negativos), con un patrón de herencia claramente autosómico dominante (tres generaciones consecutivas comprometidas en línea directa) y excelente control con dosis bajas de sulfonilureas (glibenclamida), constituye la presentación canónica de Diabetes MODY (habitualmente MODY-3 por mutación en el factor nuclear HNF-1alfa).

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: C**

1.04.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS**

Una glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL corresponde a una Glicemia de Ayuno Alterada (prediabetes). La conducta establecida en las guías clínicas del MINSAL ante este hallazgo es solicitar una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 gramos de glucosa anhidra para evaluar si el paciente presenta intolerancia a la glucosa oral (140-199 mg/dL a las 2 horas) o diabetes mellitus encubierta (≥ 200 mg/dL). No se debe repetir la glicemia de ayuno porque ya sabemos que está en rango prediabético.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: C**

1.04.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS**

La presencia de síntomas cardinales clásicos de hiperglicemia (polidipsia, poliuria/nicturia, visión borrosa) en combinación con una glicemia casual tomada en cualquier momento del día ≥ 200 mg/dL cumple de forma definitiva y autónoma el criterio de confirmación de Diabetes Mellitus. En este escenario no se requiere ni se debe postergar el diagnóstico esperando una segunda muestra en ayunas, debiendo iniciarse el plan terapéutico de inmediato.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

1.04.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS**

En pacientes hospitalizados con procesos infecciosos o sépticos agudos graves, la liberación masiva de hormonas de contrarregulación (cortisol, catecolaminas, glucagón) induce hiperglicemia de estrés incluso en pacientes no diabéticos. En este contexto, la glicemia plasmática no sirve para diagnosticar diabetes de base. El examen de elección es la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), ya que refleja el promedio glucémico de los 2 a 3 meses previos al evento agudo; un valor ≥ 6.5% certifica diabetes previa a la hospitalización.

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

1.04.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS**

El paciente presentó una primera glicemia compatible con sospecha de diabetes (≥ 126 mg/dL), pero la segunda muestra resultó discordante (< 126 mg/dL, específicamente 115 mg/dL, en rango de glicemia de ayuno alterada). Ante resultados discordantes en ayuno, la regla diagnóstica de la ADA y las guías chilenas indica desempatar el cuadro solicitando una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO con 75 g), la cual determinará si el valor a las 2 horas es normal (< 140), intolerante (140-199) o diabético (≥ 200).

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

1.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)**

agregar insulina

**PREGUNTA 18** **Respuesta: E**

1.02.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas**

Tiene acantosis nigricans, clásico de la RI.

## BLOQUE 2 FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: B**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL**

El paciente presenta falla terapéutica a la monoterapia con metformina en dosis estándar (1.700 mg/día), persistiendo con una HbA1c de 8.4% a los 6 meses (meta < 7.0%). Según las guías clínicas del MINSAL para DM2 (GES N° 2), ante el fracaso de la monoterapia en un paciente asintomático sin descompensación catabólica aguda, la conducta indicada es mantener la metformina y escalar a biterapia oral asociando un segundo agente (como una sulfonilurea, ej. glibenclamida 2.5 a 5 mg/día, o un inhibidor de DPP-4).

**PREGUNTA 20** **Respuesta: C**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL**

El paciente debuta con una diabetes mellitus severamente descompensada caracterizada por marcada glucotoxicidad (HbA1c > 10% y glicemia > 300 mg/dL), catabolismo acelerado con baja de peso significativa y cetonuria incipiente. En este escenario, las células beta pancreáticas se encuentran aturdidas e incapaces de responder a hipoglucemiantes orales aislados. La indicación indiscutida es iniciar de inmediato insulinoterapia (insulina NPH basal nocturna ± insulina rápida), pudiendo asociarse metformina para mitigar la resistencia a la insulina.

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL**

La Garantía Explícita en Salud (GES N° 2) para Diabetes Mellitus Tipo 2 establece plazos legales perentorios: la confirmación diagnóstica debe realizarse dentro de 45 días desde la sospecha clínica en APS, pero una vez confirmado el diagnóstico, el inicio del tratamiento médico (farmacológico y nutricional) debe garantizarse dentro de las 24 HORAS siguientes a dicha confirmación.

**PREGUNTA 22** **Respuesta: C**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL**

Los grandes ensayos clínicos contemporáneos (DAPA-HF, EMPEROR-Reduced) y las guías de la ADA y la Sociedad Europea de Cardiología han establecido que en pacientes con DM2 y comorbilidad de Insuficiencia Cardíaca con FEVI reducida, los inhibidores de SGLT2 (como dapagliflozina o empagliflozina) son los fármacos de elección prioritaria independientemente del nivel de HbA1c, ya que reducen drásticamente las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular. La pioglitazona (B) está contraindicada por retener líquido.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: A**

1.04.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL**

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL, la conducta médica prioritaria es: La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

1.04.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas**

La metformina se elimina íntegramente por filtración glomerular y secreción tubular renal. Cuando la VFG desciende por debajo de 30 mL/min/1.73m², el fármaco se acumula exponencialmente en los tejidos, inhibiendo la fosforilación oxidativa mitocondrial e induciendo la temida Acidosis Láctica asociada a Metformina (MALA), cuadro de altísima letalidad. Por tanto, una VFG < 30 constituye una contraindicación absoluta e inmediata de metformina.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

1.04.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas**

Las hipoglicemias secundarias a sulfonilureas de larga vida media como la glibenclamida son recurrentes y prolongadas debido a la persistencia del fármaco y sus metabolitos activos en la circulación, especialmente en adultos mayores con menor clearence renal. Aunque el paciente se recupere completamente con el bolo inicial de glucosa, el estímulo insulínico continúa y volverá a presentar hipoglicemia severa horas más tarde. Es imperativo hospitalizarlo con aporte continuo de suero glucosado al 10% por 24 horas.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

1.04.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4**

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2) como la dapagliflozina actúan bloqueando la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, excretando grandes cantidades de azúcar por la orina (glucosuria). El aumento de la concentración de glucosa en el tracto urogenital favorece la colonización y proliferación fúngica, siendo las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal en mujeres y balanitis en hombres) el efecto adverso más común (5 a 10% de los pacientes).

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: C**

1.04.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4**

A diferencia de la sitagliptina y vildagliptina, que se eliminan principalmente por vía renal y requieren ajuste posológico según la VFG, la linagliptina se excreta en más del 80–90% por vía enterohepática a través de la bilis y las heces. Por este motivo, la linagliptina no requiere ningún ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal en cualquier etapa (incluyendo pacientes en hemodiálisis o VFG < 15 mL/min), constituyendo una opción oral muy segura en nefropatía.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: C**

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante**

La paciente presenta un fracaso de la terapia nutricional (> 20% de glicemias postprandiales sobre 140 mg/dL a la hora). Como las glicemias de ayuno son normales, no requiere insulina basal NPH nocturna. El tratamiento indicado es la adición de insulina prandial de acción rápida (cristalina o análogos lispro/aspart) administrada antes del almuerzo y la cena para aplanar los peaks glucémicos postprandiales. Los hipoglucemiantes orales como la glibenclamida están contraindicados.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

1.04.2.001, 1.04.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante**

La hiperglicemia materna en la segunda mitad del embarazo atraviesa la placenta libremente por difusión facilitada, estimulando al páncreas fetal a producir grandes cantidades de insulina (la cual no cruza la placenta). La insulina actúa en el feto como una potente hormona de crecimiento y anabolizante, provocando acumulación grasa en tronco y hombros (macrosomía fetal), con alto riesgo de distocia de hombros en el parto y de hipoglicemia neonatal grave tras el corte del cordón umbilical por cese brusco del aporte materno de glucosa. Las malformaciones mayores (A y B) son propias de la diabetes pregestacional descompensada en el primer trimestre.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

1.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hipertensión arterial en diabetes tipo 2" (1.02.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: E**

1.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

Por tener HbA1c mayor a 7%, se debe avanzar en el tratamiento. Además, por la IRC están contraindicados la mayoría de los hipoglicemiantes orales, siendo indicación de insulina. Como alternativa modera están los agonistas GLP-1, como la semagluGda, liragluGda y dulagluGda. Los inhibidores SGLT-2, como la empaglifozina y la dapaglifozina, en cambio, requieren de una función renal adecuada para funcionar, ya que justamente bajan los niveles de azúcar, mediante glucosuria. Ambos, GLP- 1 y SGLT-2 son úGles en riesgo cardiovascular elevado, siendo una alternativa a la insulina.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: D**

1.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

La insuficiencia renal contraindica los hipoglicemiantes orales: se debe dejar insulina. El tratamiento que tenía era pésimo.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

1.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

Hay dos formas de enfrentar esta pregunta. 1. Paciente mayor de 75 años, el objetivo de hemoglobina glicosilada es menor a 8%, por tanto, está sobretratado y se puede suspender la me~ormina. 2. Tiene una insuficiencia renal crónica avanzada (creaGnina 3,8 mg/dl equivale a un clearence bajo 15 ml/min), por lo que está contraindicada la me~ormina. Los demás fármacos se pueden mantener, especialmente tomando en cuenta que su presión arterial sigue elevada (objetivo en mayores de 75 años suele ser <140-150/90 mmHg, en la mayoría de las fuentes) y que los electrolitos están normales.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: A**

1.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

Por la crea de 1,5

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En todo paciente diabético hipertenso que presente albuminuria patológica (RAC ≥ 30 mg/g, en este caso 180 mg/g), el fármaco antihipertensivo de primera línea indiscutido según todas las guías de práctica clínica (ADA, KDIGO y MINSAL) es un inhibidor de la ECA (como Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (como Losartán). Estos agentes vasodilatan selectivamente la arteriola eferente, disminuyendo la presión capilar intraglomerular y confiriendo un beneficio nefroprotector directo superior a otros hipotensores.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

**Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La angiotensina II endógena genera una potente vasoconstricción sobre la arteriola eferente, lo que eleva de forma patológica la presión hidrostática dentro del ovillo capilar glomerular en la diabetes. Al bloquear la síntesis de angiotensina II con un IECA (enalapril), se produce una vasodilatación predominante de la arteriola eferente, disminuyendo la presión intraglomerular (presión de filtración), lo que alivia el estrés mecánico sobre los podocitos y disminuye notablemente la albuminuria.

## BLOQUE 3 INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

**Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio**

1.04.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio, la conducta médica prioritaria es: La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: C**

**Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio**

1.04.1.004, 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta síntomas catabólicos francos (baja de peso de 6 kg, poliuria, polidipsia) y una HbA1c de 10.8% pese a estar en biterapia oral a dosis plenas. La indicación indiscutida en la guía GES de DM2 y normas internacionales es el inicio de insulinoterapia basal (NPH nocturna 0.1-0.2 UI/kg o 10 UI bedtime), manteniendo la metformina para mitigar el aumento de peso y mejorar la sensibilidad insulínica.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio**

1.04.1.004, 1.04.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La insulina NPH presenta un pico de acción máximo entre 4 y 10 horas después de su inyección subcutánea. Si se administra con la cena (20:00 hrs), su pico coincide con el nadir fisiológico de glicemia entre las 02:00 y 04:00 AM, provocando hipoglicemias nocturnas sintomáticas. La medida clásica recomendada es trasladar la inyección de NPH al momento de acostarse ("bedtime", 22:30-23:00 hrs), desplazando el pico hacia las 06:00-08:00 AM, donde coincide con el despertar y el desayuno.

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

**Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis**

1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La insulina cristalina administrada antes de una comida tiene como función específica controlar la excursión glucémica postprandial producida por dicha ingesta. Dado que el paciente presenta exclusivamente hiperglicemias postprandiales tras el almuerzo (220-250 mg/dL), manteniendo el resto de sus mediciones en rangos óptimos, la conducta terapéutica precisa es aumentar la dosis de insulina cristalina administrada antes del almuerzo.

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis**

La hiperglicemia matinal en ayunas en un paciente con insulina basal nocturna puede deberse a dos fenómenos con manejos radicalmente opuestos: el Efecto Somogyi (hipoglicemia nocturna que desencadena rebote hiperglicémico por hormonas contrarreguladoras) o el Fenómeno del Alba (hiperglicemia por secreción matinal de GH y cortisol). La única manera de diferenciarlos con certeza es medir la glicemia capilar en la madrugada (alrededor de las 03:00 AM). Si es baja (< 70 mg/dL) se reduce la insulina nocturna; si es normal o alta, se incrementa.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: C**

1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis**

La paciente presenta glicemias de ayuno persistentemente elevadas (> 180 mg/dL) con una medición a las 03:00 AM también elevada (145 mg/dL), lo que descarta de plano un efecto Somogyi y confirma que la dosis de insulina basal nocturna es insuficiente. Según el algoritmo de titulación de insulina basal, ante glicemias de ayuno > 180 mg/dL se debe incrementar la dosis de insulina basal nocturna en 4 unidades (de 14 a 18 UI), reevaluando en 3 a 5 días.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

1.04.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis**

El paciente ha alcanzado la meta de glicemia de ayuno mediante su insulina basal nocturna, pero persiste fuera de la meta de HbA1c (< 7.0%) debido a excursiones hiperglicémicas postprandiales marcadas concentradas exclusivamente en el almuerzo (230-260 mg/dL). La conducta de intensificación avalada internacionalmente es la transición a un esquema Basal-Plus, incorporando un bolo de insulina prandial (rápida o ultrarrápida, 4 UI o 10% de la basal) inmediatamente antes del almuerzo.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

1.04.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado**

En todo paciente hospitalizado con sepsis, falla renal aguda o hipotensión, la metformina debe suspenderse de inmediato ante el elevado riesgo de acidosis láctica. Asimismo, el uso exclusivo del "esquema móvil" está contraindicado por su ineficacia y variabilidad. La conducta correcta y estándar es iniciar insulinoterapia programada mediante un esquema basal (NPH o análogo prolongado) complementado con dosis de corrección de insulina rápida subcutánea, buscando una meta glicémica entre 140 y 180 mg/dL.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: C**

1.04.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado**

Las guías clínicas internacionales (ADA, Endocrine Society) y los consensos hospitalarios establecen que la meta de glicemia recomendada para la gran mayoría de los pacientes hospitalizados (tanto críticos como no críticos en salas de medicina) es de 140 a 180 mg/dL (7.8 a 10.0 mmol/L). Intentar descensos a valores < 110 mg/dL no reduce complicaciones infecciosas y se asocia a un aumento drástico de hipoglicemias severas y mortalidad global.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: C**

1.02.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

Está con hipoglicemias por insulina. La NPH nocturna es la que determina las gli- cemias a las 3 a.m., por lo que se debe disminuir esa.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: C**

1.02.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

La glibenclamida tiene alto riesgo de hipoglicemia. Además, este es el típico caso en que el paciente mal controlado decide "autorreforzar" su tratamiento, después de que los exámenes le salen mal, produciendo hipoglicemias. Que haya tenido glicemia alta antes, no impide que ahora esté baja. De las demás opciones, solo la hiponatremia produce convulsiones con cierta frecuencia.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: C**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.02.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tanto por la clínica, como por el antecedente de glibenclamida, lo más probable es que tenga hipoglicemias (probablemente se sintió mal de haber estado mal controlado e intentó arreglar sus glicemias subiendo la dosis de GBC).

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.02.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Dumping tardío: hipoglicemia 1-3h postprandial por liberación exagerada de insulina tras la hiperglicemia inicial del dumping precoz. Exclusivo del bypass gástrico. Tratamiento: comidas pequeñas y frecuentes, reducción de carbohidratos simples, acarbosa.

**PREGUNTA 50** **Respuesta: D**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.02.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene clínica de hipoglicemias, que probablemente son causadas por la glibenclamida. Por eso se debe cambiar por otro hipoglicemiante. Como tiene un mal control metabólico (HbA1c alta), no se debe agregar la colación

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.04.1.018, 1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La glibenclamida es una sulfonilurea de acción prolongada cuyos metabolitos activos tienen una depuración muy lenta, especialmente en pacientes ancianos con filtración glomerular reducida. Aunque la glucosa endovenosa en bolo revierta temporalmente la neuroglucopenia, el fármaco continúa circulando y produciendo hiperinsulinismo, por lo que la hipoglicemia reaparecerá inexorablemente horas después. La norma clínica exige hospitalizar al paciente por un periodo de 24 a 48 horas con aporte continuo de glucosa parenteral.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: C**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.04.1.018, 1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La secreción endógena de insulina por las células beta pancreáticas libera equimolarmente insulina y péptido C a la circulación portal. Por lo tanto, tanto en el estado fisiológico como en la presencia de un insulinoma o tras la ingesta de sulfonilureas, la elevación de la insulina plasmática se acompaña de un péptido C elevado. La combinación patognomónica de insulina plasmática muy alta con péptido C suprimido o indetectable es diagnóstica de administración exógena de insulina (habitualmente formulaciones farmacéuticas que carecen de péptido C), configurando un cuadro de hipoglicemia facticia.

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.04.1.018, 1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En todo paciente con hipoglicemia Nivel 1 o 2 que se encuentre consciente y con la vía oral preservada, el tratamiento de elección es la "Regla de los 15": administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida por vía oral (ej. medio vaso de bebida azucarada, agua con 3 cucharaditas de azúcar o 150 ml de jugo), aguardar 15 minutos en reposo y verificar con un nuevo hemoglucotest que la glicemia supere los 70 mg/dL.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: C**

**Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate**

1.04.1.018, 1.04.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Los betabloqueadores no cardioselectivos como el propranolol bloquean los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos, suprimiendo las manifestaciones mediadas por la descarga simpática ante la hipoglicemia (taquicardia, palpitaciones, temblores y ansiedad). Esto priva al paciente de sus señales de alarma tempranas, favoreciendo el desarrollo de hipoglicemias severas inadvertidas. Es un concepto clásico del EUNACOM que la sudoración (diaforesis) suele persistir, ya que está mediada por receptores colinérgicos muscarínicos simpáticos.

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Déficit agudo de tiamina** 1.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 22). Evalúa el manejo clínico de Déficit agudo de tiamina según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Neuropatía diabética" (1.02.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.02.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Acidosis láctica" como urgencia clínica (1.02.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.02.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Es una cetoacidosis diabética clásica (acidosis metabólica y diabetes tipo 1).

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.02.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es un síndrome hiperglicémico hiperosmolar (Sd. HGHO) clásico, cuyo otro nombre es “coma hiperosmolar no cetósico”. No hay acidosis (cetoacidosis requiere pH < 7,3 y HCO3 < 15 mEq/L). Se puede estimar la osmolaridad con una fórmula (Osmolaridad = 2xfía + BUN/2,8 + glicemia/18, que en este caso, sin tomar en cuenta el BUN ya da 350 mOsm/L), sin embargo, suele bastar una glicemia mayor a 600 para que con alVsima probabilidad cumpla el criterio de la osmolaridad > 320 mOsm/L, propio del Sd. HGHO).

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.02.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome hiperosmolar no cetósico" como urgencia clínica (1.02.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: B**

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta todos los criterios diagnósticos de una Cetoacidosis Diabética Severa (pH arterial < 7.25, bicarbonato < 15 mEq/L, glicemia > 250 mg/dL, cetonuria marcada y un Anion Gap marcadamente elevado de 134 - [98 + 11] = 25 mEq/L). La taquipnea profunda corresponde a la respiración de Kussmaul y el dolor abdominal es un síntoma frecuente de la cetoacidosis en pacientes jóvenes que no traduce una urgencia quirúrgica abdominal.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH): glicemia marcadamente elevada (> 600 mg/dL, en este caso 850 mg/dL), pH arterial normal (> 7.30), bicarbonato normal (> 18 mEq/L), ausencia de cetonuria y una osmolaridad plasmática efectiva marcadamente elevada: 2 * 152 + (850 / 18) = 304 + 47.2 = 351.2 mOsm/kg (muy superior al umbral de 320 mOsm/kg), lo cual explica el estupor y la deshidratación extrema de 8 a 12 litros desencadenada por una infección respiratoria.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

La osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad refleja la concentración de solutos que no atraviesan libremente las membranas celulares y que, por ende, generan desplazamientos osmóticos de agua entre los compartimentos intra y extracelular. Se calcula como: 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18 (en mg/dL). La urea (BUN) se excluye de este cálculo porque es un osmol libremente permeable que no contribuye a la deshidratación intracelular cerebral.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: C**

1.04.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)**

La paciente presenta una acidosis metabólica con Anion Gap aumentado (138 - [101 + 12] = 25 mEq/L) y cetonemia marcadamente positiva (4.2 mmol/L), pero con glicemia < 200 mg/dL (188 mg/dL). Esta es la presentación clásica de la Cetoacidosis Diabética Euglicémica desencadenada por inhibidores del cotransportador SGLT2 (como empagliflozina o dapagliflozina) en situaciones de estrés metabólico, ayuno o cirugía, donde la glucosuria forzada mantiene la glicemia engañosamente baja.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: C**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH**

En el manejo inicial de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, la prioridad terapéutica absoluta número uno es la restauración del volumen intravascular y la perfusión tisular mediante la administración inmediata de cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico 0.9% a 1.000–1.500 ml/h o 15–20 ml/kg/h). La insulina jamás debe administrarse antes de iniciar la hidratación porque induciría una caída del volumen intravascular al arrastrar agua al interior celular, precipitando un shock refractario.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH**

Cuando la glicemia desciende a valores ≤ 200 mg/dL en CAD, es obligatorio incorporar Suero Glucosado al 5% (o suero glucosalino) a la fluidoterapia endovenosa y disminuir la velocidad de infusión de insulina (a 0.02-0.05 UI/kg/h). La razón fundamental es que la cetoacidosis NO está resuelta (pH < 7.30, bicarbonato < 18 mEq/L y Anion Gap aún abierto en 16 mEq/L); por ende, no se puede suspender la insulina sin reactivar la cetogénesis, requiriéndose glucosa exógena para prevenir una hipoglicemia severa mientras se completa la resolución metabólica.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH**

Para decidir el fluido de mantenimiento se debe calcular el sodio corregido: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100) = 140 + 1.6 * ((900 - 100) / 100) = 140 + 1.6 * 8 = 140 + 12.8 = 152.8 mEq/L. Al resultar el sodio corregido francamente hipernatrémico (> 145 mEq/L), existe un déficit masivo de agua libre que debe reponerse con una solución hipotónica como la Solución Salina al 0.45% (NaCl 0.45%) a 250–500 ml/h.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: C**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH**

El objetivo de descenso glucémico seguro en el manejo de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es de 50 a 75 mg/dL por hora (o aproximadamente un 10% del valor basal por hora). Descensos más bruscos o violentos (> 100 mg/dL/h) provocan caídas drásticas y precipitadas de la osmolaridad sérica eficaz, generando un gradiente osmótico favorable a la entrada masiva de agua hacia el parénquima cerebral con el consecuente edema cerebral agudo.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato**

En presencia de hipokalemia con potasio sérico < 3.3 mEq/L, la administración de insulina debe retrasarse de manera obligatoria. La insulina promueve la entrada masiva de potasio hacia el interior de las células mediante la activación de la bomba Na+/K+ ATPasa; si se administra con niveles < 3.3 mEq/L puede precipitar una hipokalemia fulminante con arritmias cardíacas fatales, parada cardíaca y parálisis de los músculos respiratorios. Se debe aportar potasio a 20-30 mEq/h y solo iniciar insulina cuando el potasio supere los 3.3 mEq/L.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato**

La administración de bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética no ha demostrado beneficio en la morbimortalidad y se asocia a riesgos graves como hipokalemia severa, retraso en la caída de cuerpos cetónicos y acidosis paradójica en el sistema nervioso central. Por lo tanto, su indicación se encuentra estrictamente limitada a aquellos pacientes con acidosis extrema potencialmente letal con un pH < 6.90.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: C**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea**

Dado que la vida media de la insulina endovenosa es de apenas 5 a 9 minutos, si la bomba se suspende al mismo tiempo que se administra la insulina subcutánea (la cual demora al menos 60 a 90 minutos en alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos en el caso de la NPH o Glargina), se produce una ventana temporal sin insulina circulante que desencadena un rebote de la lipólisis y recaída de la cetoacidosis. La regla mandatoria es aplicar la insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa activa durante 1 a 2 horas de superposición.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

1.04.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea**

Los criterios diagnósticos de resolución de la CAD establecidos por la ADA y el Ministerio de Salud son: Glicemia < 200 mg/dL acompañada de al menos dos de los siguientes tres criterios: 1) pH venoso > 7.30; 2) Bicarbonato sérico ≥ 18 mEq/L; y 3) Anion Gap normalizado (≤ 12 mEq/L). La opción B cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos requisitos.

---

## BLOQUE 5 COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Vasculopatía periférica**

1.02.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vasculopatía periférica" (1.02.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: C**

1.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector**

Atorvastatina

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: C**

**Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector**

1.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Si bien tiene todos los lípidos malos, tiene una hipercolesterolemia LDL muy elevada, por lo que requiere estatinas. Las mialgias, por lo general se estudian con CK. Si están normales, se evalúa mantener el tratamiento. Si están elevadas, se debe evaluar el riesgo / beneficio de la estatina. La rosuvastatina es de bajo riesgo de mialgias, al igual que la atorvastatina, por lo que, de las opciones, parece la más correcta, dado que los demás fármacos no son buenos para la hipercolesterolemia LDL.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector**

1.02.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Nefropatía incipiente" (1.02.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A**

**Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente tiene confirmada una nefropatía diabética incipiente en etapa de microalbuminuria persistente (RAC entre 30 y 299 mg/g en dos tomas consecutivas sin factores de confusión). Las guías internacionales y del MINSAL indican unánimemente que todo paciente diabético con albuminuria persistente debe recibir un bloqueador del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA como enalapril o ARA II como losartán), independientemente de sus cifras de presión arterial, dado su efecto hemodinámico específico dilatador de la arteriola eferente que frena la progresión del daño renal.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

**Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector**

1.04.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A diferencia de la DM1 (donde el daño microvascular tarda al menos 5 años en manifestarse), en la diabetes mellitus tipo 2 suele existir un periodo subclínico asintomático prolongado (de 4 a 7 años) previo a la detección clínica. Por lo tanto, un porcentaje importante de pacientes ya presenta complicaciones microvasculares al momento del debut, por lo que el tamizaje anual de nefropatía (RAC y VFG) y de retinopatía (fondo de ojo) debe iniciarse desde el momento mismo del diagnóstico.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: D**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES**

1.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

subir metformina??

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: B**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES**

1.04.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La alteración anatomopatológica inicial de la retinopatía diabética es la pérdida de pericitos capilares y la dilatación sacular de los capilares de la retina interna. Estas dilataciones son visibles al fondo de ojo como pequeños puntos rojos oscuros de bordes redondeados y muy bien delimitados conocidos como microaneurismas, constituyendo la primera lesión clínica e histopatológica demostrable.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: C**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES**

1.04.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La pérdida súbita e indolora de la visión acompañada de abolición del rojo pupilar ("ojo que no deja ver la retina al oftalmoscopio") en un paciente con DM2 de larga data es la manifestación clásica de una Hemorragia Vítrea. Esta ocurre por la rotura de neovasos frágiles característicos de la Retinopatía Diabética Proliferativa. Debe derivarse de forma urgente a evaluación oftalmológica para estudio ecográfico y resolución mediante vitrectomía posterior o panfotocoagulación según corresponda.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

**Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico**

1.04.1.014, 1.04.1.015 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La prueba del estilete óseo ("probe-to-bone test") consiste en palpar hueso en el fondo de la úlcera mediante una sonda metálica estéril. Su positividad confirma con altísima sensibilidad y especificidad (> 90%) la existencia de una osteomielitis subyacente, lo que clasifica la lesión automáticamente como Grado 3 de Wagner. El manejo estándar exige la hospitalización inmediata del paciente para desbridamiento y aseo quirúrgico, obtención de muestras óseas para cultivo microbiológico y terapia antibiótica parenteral prolongada.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

**Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico**

1.04.1.014, 1.04.1.015 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

El monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07, calibrado para aplicar exactamente una fuerza de 10 gramos al doblarse contra la piel, es el método estándar de oro, no invasivo, económico y universalmente recomendado en las guías del MINSAL y la ADA para la detección sistemática de la pérdida de la sensibilidad protectora en el pie diabético.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: C**

**Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico**

1.04.1.014, 1.04.1.015 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

En la clasificación de Wagner, el Grado 4 se define como la presencia de gangrena localizada y limitada a los dedos, antepié o talón (isquemia tisular focalizada). El Grado 5 corresponde a una gangrena extensa que compromete todo el pie o gran parte de la extremidad con repercusión sistémica severa.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico**

1.04.1.014, 1.04.1.015 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

En toda úlcera superficial de pie diabético (Wagner 1), la medida no negociable y determinante para lograr la cicatrización es la descarga de la presión y del traumatismo mecánico ("off-loading") sobre la zona lesionada (mediante calzado terapéutico modificado, reposo o férula), combinada con curaciones avanzadas que mantengan un ambiente húmedo y limpio. Ninguna terapia tópica o antibiótica será efectiva si la zona continúa sufriendo roce o impacto repetitivo.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: C**

**Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas**

1.04.1.020, 1.04.1.021 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

En todo paciente con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica confirmada (prevención secundaria por infarto de miocardio previo), el riesgo cardiovascular es clasificado como Muy Alto. La meta terapéutica obligatoria de colesterol LDL es alcanzar niveles < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL según guías actuales) o reducir al menos el 50% del valor basal. Por ello, una dosis de 10 mg de atorvastatina es insuficiente, debiendo indicarse una estatina de alta intensidad como Atorvastatina 40 a 80 mg/día.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: B**

**Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas**

1.04.1.020, 1.04.1.021 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

Las estatinas pueden producir una gama de eventos adversos musculares que van desde mialgias simples sin daño celular hasta miositis severa y rabdomiólisis potencialmente letal. Ante la aparición de dolor o debilidad muscular en un paciente que recibe estatinas, el examen mandatario de laboratorio inicial es la medición de la Creatina Kinasa (CK) sérica. Si la CK se encuentra normal, se trata de una mialgia simple; si supera 5 a 10 veces el valor normal con elevación de transaminasas o daño renal, se debe suspender la estatina inmediatamente.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: E**

1.02.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis**

Manejo de Hipertrigliceridemia Severa: En un paciente con dislipidemia mixta el objetivo suele ser bajar el colesterol LDL, a menos que los triglicéridos sean > 500 mg/dL, en que la prioridad es bajar los triglicéridos. Con niveles > 1000 mg/dL, hay alto riesgo de pancreatitis, por lo que se debe manejar urgentemente. Hace años incluso se recomendaba hospitalizarlos para el manejo, sin embargo esa recomendación actualmente está obsoleta (tal vez el Eunacom aún la considera). La medida más importante o urgente es la suspensión inmediata del consumo de alcohol y una dieta estricta baja en glúcidos y baja en grasas. En paralelo, se inician los fibratos (gemfibrozilo)..

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: B**

1.04.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis**

Cuando los triglicéridos superan los 500 a 1.000 mg/dL, la complicación inmediata más grave que amenaza la vida del paciente no es la ateroesclerosis coronaria sino la Pancreatitis Aguda por hipertrigliceridemia (por toxicidad directa de los ácidos grasos libres sobre el tejido acinar pancreático). La prioridad absoluta es reducir rápidamente los triglicéridos mediante el inicio de un fibrato (fenofibrato 160–200 mg/d o gemfibrozilo 600 mg c/12h), sumado a la abstención completa de alcohol y azúcares simples.

---

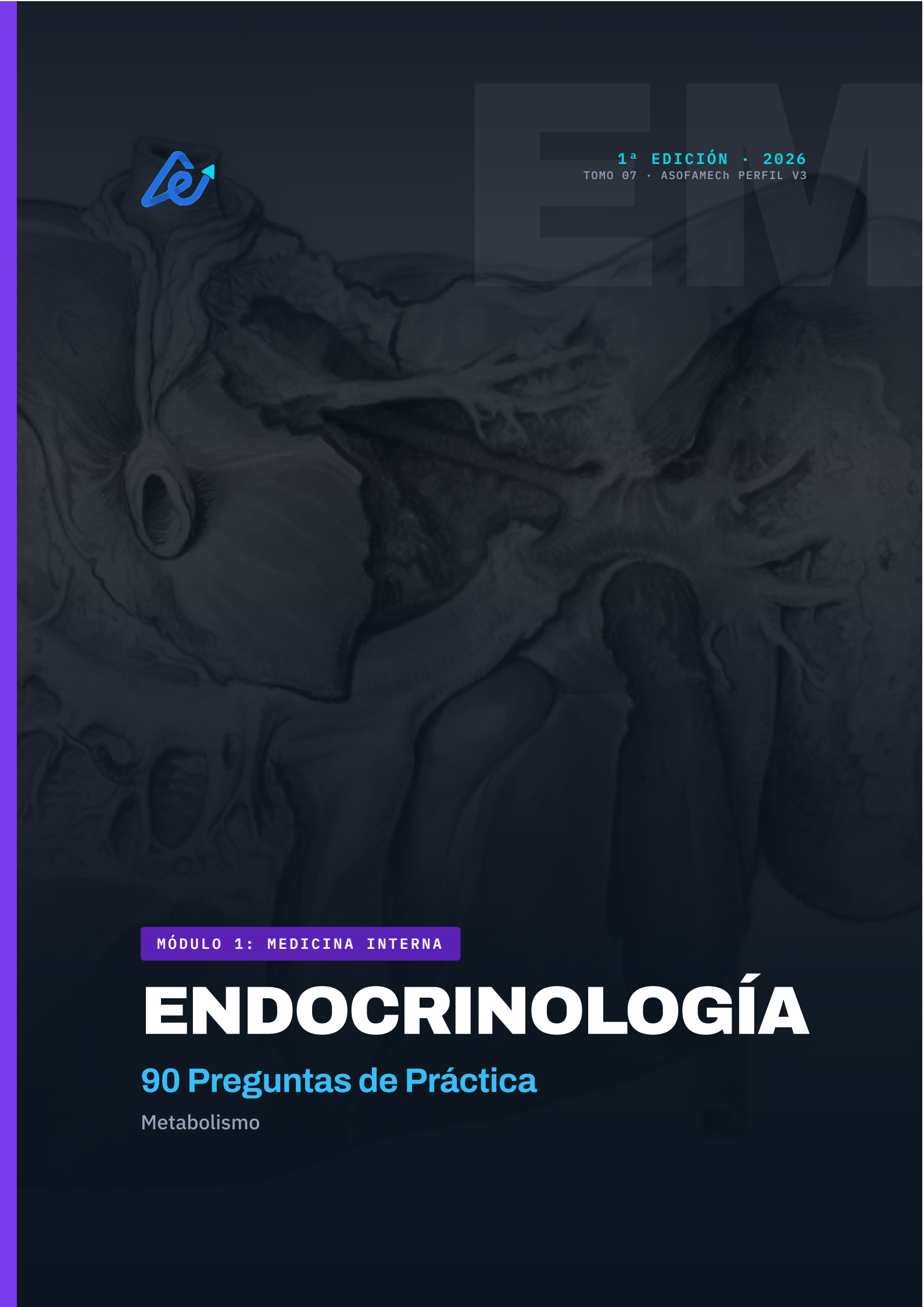
**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

1.04.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis**

El paciente presenta los hallazgos clásicos de una Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota: elevación extrema de colesterol LDL (> 190 mg/dL, en este caso 266 mg/dL), presencia de xantomas tendinosos en los tendones de Aquiles (estigma físico patognomónico que traduce depósito tisular de ésteres de colesterol por macrófagos espumosos) y antecedentes de primer grado de enfermedad coronaria prematura (padre con infarto a los 41 años). Se transmite de forma autosómica dominante por mutaciones del receptor LDL.

---



1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 07 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# ENDOCRINOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Metabolismo

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Endocrinología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS** | | | | | |
| 1.03.1.002 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q1 | Tomo 07 · C.2 (Pág. 8) |
| 1.03.1.005 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q2 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.011 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q3 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.017 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.2.002 | Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 07 · C.4 (Pág. 12) |
| 1.03.2.004 | Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 07 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.05.1.005 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q16, Q17 | Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.2.003 | Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15 | Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11) |
| 4.01.1.013 | Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16, Q17 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |
| **BLOQUE 2: BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES** | | | | | |
| 1.03.1.001 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 07 · C.1 (Pág. 6) |
| 1.03.1.003 | Hipertiroidismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24) |
| 1.03.1.004 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 07 · C.52 (Pág. 108) |
| 1.03.1.021 | Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.2.001 | Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q28 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.04.1.002 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q32 | Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tx: **Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía** · Seg: **Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo** | | | |
| 1.04.1.003 | Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF | Dx: **TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA** Tx: **Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx)** · Seg: **Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50) |
| **BLOQUE 3: BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA** | | | | | |
| 1.03.1.006 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q38 | Tomo 07 · C.8 (Pág. 20) |
| 1.03.1.007 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44 | Tomo 07 · C.9 (Pág. 22) |
| 1.03.1.008 | Hirsutismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.019 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.022 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.2.003 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46 | Tomo 07 · C.5 (Pág. 14) |
| 1.04.1.005 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática** Tx: **Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | · Seg: **Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje** | | | |
| 1.04.1.006 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria** Tx: **Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés** · Seg: **Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático** | GES | Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52 | Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55) |
| 1.04.1.007 | Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria | Dx: **Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal** Tx: **Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona)** · Seg: **Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)** | GES | Q53, Q54 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |
| **BLOQUE 4: BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO** | | | | | |
| 1.03.1.018 | Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 07 · C.34 (Pág. 72) |
| 1.03.1.020 | Hipercalcemias e hipocalcemias | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60 | Tomo 07 · C.21 (Pág. 46) |
| 1.03.2.005 | Tetania | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 07 · C.7 (Pág. 18) |
| 1.04.1.009 | Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico | Dx: **Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D** Tx: **Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios** · Seg: **Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'** | | | |
| 1.04.1.010 | Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia | Dx: **Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek)** Tx: **Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia** · Seg: **Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico** | GES | Q66, Q67 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.1.011 | Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento | Dx: **Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad** Tx: **1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d)** · Seg: **DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular** | GES | Q69, Q70 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.012 | Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo | Dx: **25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima** Tx: **Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de** | GES | Q71, Q72 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **mantención 1.000-2.000 UI/día** · Seg: **Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia** | | | |
| **BLOQUE 5: BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN** | | | | | |
| 1.03.1.009 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.010 | Amenorrea | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.012 | Hipogonadismo masculino | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.013 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.014 | Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.015 | Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 07 · C.17 (Pág. 38) |
| 1.03.1.016 | Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.023 | Ginecomastia | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.04.1.013 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios**<br>Tx: **Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente** · Seg: **RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico** | GES | Q78, Q79 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.1.014 | Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica | Dx: **Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico**<br>Tx: **1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO).** | GES | Q81, Q82 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia** · Seg: **Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas** | | | |
| 1.04.1.015 | Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo | Dx: **Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L)** Tx: **1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido)** · Seg: **Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma** | GES | Q83, Q84 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |
| 1.04.1.016 | Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo | Dx: **Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH)** Tx: **Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina** · Seg: **Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH** | GES | Q86, Q87 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |
| 1.04.1.017 | Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) | Dx: **Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100)** Tx: **DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH:** | GES | Q89, Q90 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Restricción de fluidos (500-1000 mL/d)** · Seg: **Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)** | | | |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Endocrinología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 07 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.001 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 07 · C.1 (Pág. 6) |
| 1.03.1.002 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q1 | Tomo 07 · C.2 (Pág. 8) |
| 1.03.1.003 | Hipertiroidismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24) |
| 1.03.1.004 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 07 · C.52 (Pág. 108) |
| 1.03.1.005 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q2 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.006 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q38 | Tomo 07 · C.8 (Pág. 20) |
| 1.03.1.007 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44 | Tomo 07 · C.9 (Pág. 22) |
| 1.03.1.008 | Hirsutismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.009 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.010 | Amenorrea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.011 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q3 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.012 | Hipogonadismo masculino | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.013 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.014 | Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.015 | Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 07 · C.17 (Pág. 38) |
| 1.03.1.016 | Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.017 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q4 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.018 | Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 07 · C.34 (Pág. 72) |
| 1.03.1.019 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.020 | Hipercalcemias e hipocalcemias | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60 | Tomo 07 · C.21 (Pág. 46) |
| 1.03.1.021 | Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.022 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.1.023 | Ginecomastia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.2.001 | Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q28 | Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8) |
| 1.03.2.002 | Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 07 · C.4 (Pág. 12) |
| 1.03.2.003 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q46 | Tomo 07 · C.5 (Pág. 14) |
| 1.03.2.004 | Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 07 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.03.2.005 | Tetania | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 07 · C.7 (Pág. 18) |
| 1.04.1.002 | Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos | Dx: **TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo** Tx: **Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía** · Seg: **Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo** | GES | Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q32 | Tomo 06 · 1.2 (Pág. 7) |
| 1.04.1.003 | Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF | Dx: **TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA** Tx: **Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx)** · Seg: **Control ecográfico** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 02 · 4.6 (Pág. 50) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional** | | | |
| 1.04.1.005 | Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico | Dx: **Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática** Tx: **Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona** · Seg: **Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43 | Tomo 06 · 3.2 (Pág. 39) |
| 1.04.1.006 | Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria | Dx: **Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria** Tx: **Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés** · Seg: **Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático** | GES | Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52 | Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55) |
| 1.04.1.007 | Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria | Dx: **Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal** Tx: **Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona)** · Seg: **Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con** | GES | Q53, Q54 | Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)** | | | |
| 1.04.1.009 | Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico | Dx: **Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D** Tx: **Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios** · Seg: **Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37) |
| 1.04.1.010 | Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia | Dx: **Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek)** Tx: **Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia** · Seg: **Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico** | GES | Q66, Q67 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.1.011 | Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento | Dx: **Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad** Tx: **1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d)** · Seg: **DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular** | GES | Q69, Q70 | Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59) |
| 1.04.1.012 | Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo | Dx: **25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL =** | GES | Q71, Q72 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima** Tx: **Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día** · Seg: **Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia** | | | |
| 1.04.1.013 | Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria | Dx: **RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios** Tx: **Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente** · Seg: **RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico** | GES | Q78, Q79 | Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46) |
| 1.04.1.014 | Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica | Dx: **Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico** Tx: **1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia** · Seg: **Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas** | GES | Q81, Q82 | Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27) |
| 1.04.1.015 | Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo | Dx: **Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L)** Tx: **1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del** | GES | Q83, Q84 | Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido)** · Seg: **Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma** | | | |
| 1.04.1.016 | Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo | Dx: **Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH)** Tx: **Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina** · Seg: **Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH** | GES | Q86, Q87 | Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52) |
| 1.04.1.017 | Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) | Dx: **Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100)** Tx: **DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d)** · Seg: **Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)** | GES | Q89, Q90 | Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48) |
| 1.05.1.005 | Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q16, Q17 | Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.2.003 | Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15 | Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11) |
| 4.01.1.013 | Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16, Q17 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS

PREGUNTA 1 1.03.1.002

**1. Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. ¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examem físico?**

A) Mixedema pretibial
B) Exoftalmo
C) Melanoplaquias
D) Piel seca
E) Acantosis nigricans

PREGUNTA 2 1.03.1.005

**2. Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?**

A) Tiamazol
B) AINEs
C) Propiltiouracilo
D) Bloqueadores beta
E) Yodo radioactiivo en dosis terapéutica

PREGUNTA 3 1.03.1.011

**3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome climatérico · 1.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome climatérico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 1.03.1.017

**4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de secreción inapropiada de ADH · 1.03.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de secreción inapropiada de ADH. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 1.05.1.005

**5. Un paciente de 68 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Paciente Crítico recibiendo soporte hemodinámico y ventilatorio por una pancreatitis aguda necrohemorrágica grave con falla multiorgánica. En sus exámenes de laboratorio se documenta: TSH 0.8 mIU/L (normal 0.4–4.0), T4 libre 0.85 ng/dL (normal 0.8–1.9), T3 total 32 ng/dL (normal 80–200) y T3 reversa marcadamente elevada. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada respecto a este perfil hormonal?**

A) Iniciar levotiroxina endovenosa en dosis sustitutiva completa
B) Iniciar triyodotironina (T3) oral por sonda nasoyeyunal
C) Mantener conducta expectante respecto al eje tiroideo y continuar el tratamiento intensivo de la pancreatitis
D) Iniciar hidrocortisona endovenosa en altas dosis para reactivar la secreción tiroidea
E) Solicitar tiroidectomía de urgencia para evitar tormenta tiroidea larvada

PREGUNTA 6 1.05.1.005

**6. Una mujer de 54 años consulta por astenia leve y sequedad de piel. Sus exámenes de laboratorio revelan: TSH de 7.4 mIU/L (valor de referencia 0.4 a 4.0 mIU/L) y T4 Libre de 1.2 ng/dL (valor de referencia 0.8 a 1.8 ng/dL). ¿Cuál es la interpretación diagnóstica de este examen?**

A) Hipotiroidismo primario clínico establecido
B) Hipotiroidismo subclínico
C) Hipotiroidismo central secundario
D) Resistencia a las hormonas tiroideas
E) Síndrome del eutiroideo enfermo

PREGUNTA 7 1.05.1.005

**7. Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo primario por tiroiditis de Hashimoto, con TSH de 38 mIU/L y T4 libre de 0.4 ng/dL. Como antecedentes refiere hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio hace 3 años, actualmente asintomático. ¿Cuál es la dosis inicial de levotiroxina más recomendada para este paciente?**

A) 150 mcg al día
B) 100 mcg al día
C) 1.6 mcg/kg de peso al día de inmediato
D) 25 a 50 mcg al día con titulación gradual según TSH
E) 12.5 mcg una vez a la semana en días alternos

PREGUNTA 8 1.05.1.005

**8. Una mujer de 32 años, asintomática, que desea embarazarse en los próximos meses, se realiza exámenes de control de salud que muestran: TSH de 6.8 mIU/L y T4 libre de 1.1 ng/dL (rango normal 0.8 a 1.8 ng/dL). Sus anticuerpos anti-TPO resultan positivos en títulos elevados (480 UI/mL). ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?**

A) Tranquilizar a la paciente y citar a nuevo control de TSH en 1 año sin tratamiento
B) Iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis bajas (25 a 50 mcg/día) con meta de TSH menor a 2.5 mIU/L
C) Iniciar tratamiento con propiltiouracilo para bloquear la autoinmunidad
D) Indicar dieta rica en yodo y suplementos de selenio sin fármacos
E) Solicitar una punción aspirativa con aguja fina de la glándula tiroides

PREGUNTA 9 1.05.1.005

**9. ¿A las cuántas semanas de iniciado el tratamiento con levotiroxina o de un ajuste de dosis se debe solicitar el control de TSH plasmática para evaluar la eficacia y adecuar la dosificación?**

A) A las 24 a 48 horas
B) A las 2 semanas
C) A las 6 a 8 semanas
D) A los 6 meses
E) Al año calendario

PREGUNTA 10 1.05.1.005

**10. Un paciente de 52 años en tratamiento con levotiroxina 100 mcg al día por hipotiroidismo primario acude a control con TSH de 12.8 mIU/L. Refiere que toma rigurosamente su tableta todas las mañanas junto con el desayuno, acompañada de una taza de café con leche y una pastilla de carbonato de calcio con vitamina D y sulfato ferroso que le prescribieron para osteoporosis y anemia. ¿Cuál es la causa más probable de la falta de control bioquímico?**

A) Desarrollo de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH
B) Interferencia y quelación en la absorción intestinal de levotiroxina por los alimentos, el café, el calcio y el hierro
C) Resistencia periférica severa a hormonas tiroideas de origen genético
D) Depuración renal acelerada de la hormona tiroidea por el calcio
E) Conversión periférica masiva de T4 a T3 tóxica

PREGUNTA 11 1.03.2.002

**11. Una paciente de 46 años, con antecedentes de anemia perniciosa y vi`ligo, es traída al servicio de urgencia por un cuadro de malestar general y desorientación. Sus familiaees relatan que ha presentado compromiso del estado general y astenia de 3 semanas de evolución, asociando recientemente a somnolencia y desorientación. Al examen Fsico está en sopor superficial y sus signos vitales muestran presión arterial: 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 62 lpm, temperatura: 36 °C. En el examen segmentario se obje8va lengua de gran tamaño y edema de extremidades inferiores. Al examen neurológico está soporosa, no 8ene focalidad neurológica y se observa enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos. Los exámenes de laboratorio muestran sodio: 130 mEq/L, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 31%, VCM 102 fL, glóbulos blancos: 5.200/mm³ y plaquetas: 180.000/mm³. Se solicita TAC de cerebro, que no muestra alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Suero hipertónico endovenoso
B) Suero fisiológico endovenoso
C) Levo2roxina endovenosa
D) Cor2coides endovenosos
E) An2bió2cos endovenosos

PREGUNTA 12 1.05.2.003

**12. Una paciente de 76 años es llevada a la urgencia en estado de sopor profundo durante el invierno. Al examen físico destaca temperatura axilar de 32.5 °C, frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, presión arterial de 82/50 mmHg y reflejos osteotendinosos abolidos. En sus exámenes destaca sodio plasmático de 121 mEq/L, glicemia de 62 mg/dL y una TSH de 88 mIU/L con T4 libre menor a 0.2 ng/dL. Además de intubación orotraqueal y soporte hemodinámico, ¿cuál es la medida farmacológica inmediata más importante?**

A) Administrar 500 mcg de levotiroxina endovenosa en bolo exclusivo sin corticoides
B) Administrar hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés antes o simultáneamente con la levotiroxina
C) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio y realizar recalentamiento corporal activo en tina caliente
D) Administrar metimazol endovenoso para modular la respuesta autoinmune
E) Indicar hemodiálisis de urgencia para corregir la hiponatremia

PREGUNTA 13 1.05.2.003

**13. ¿Cuál es el método de recalentamiento corporal indicado y seguro en un paciente cursando un coma mixedematoso con temperatura corporal central de 32 °C?**

A) Inmersión inmediata del paciente en baño de agua caliente a 42 °C
B) Uso de lámparas infrarrojas y calentadores radiantes sobre la piel desnuda
C) Recalentamiento pasivo con mantas convencionales en un ambiente térmico templado
D) Infusión de suero fisiológico calentado a 50 °C por vía venosa central masiva
E) No se debe recalentar al paciente hasta que la TSH descienda a menos de 10 mIU/L

PREGUNTA 14 1.05.2.003

**14. ¿Cuál de las siguientes alteraciones electrolíticas y metabólicas es característica y forma parte fundamental del síndrome de coma mixedematoso en adultos mayores?**

A) Hipernatremia hiperosmolar severa
B) Hiponatremia hiposmolar dilucional asociada a hipoglicemia
C) Hipercalcemia maligna refractaria
D) Hipokalemia severa con alcalosis metabólica
E) Cetoacidosis con elevación del Anion Gap

PREGUNTA 15 1.05.2.003

**15. Un paciente de 72 años con coma mixedematoso confirmado se encuentra intubado en la UCI recibiendo hidrocortisona EV y levotiroxina. Al monitor se observa PA 78/48 mmHg y bradicardia de 46 lpm refractaria a la administración de 2.000 ml de cristaloides. La ecocardiografía muestra derrame pericárdico moderado sin taponamiento y fracción de eyección de 35%. ¿A qué mecanismo fisiopatológico principal se atribuye la refractariedad del shock?**

A) Vasoplejía séptica pura por toxina estreptocócica
B) Depresión miocárdica severa y cronotropismo negativo inducidos por déficit crítico de hormonas tiroideas a nivel celular
C) Tromboembolismo pulmonar masivo bilateral
D) Hiperaldosteronismo secundario con escape de sodio
E) Rotura de cuerda tendinosa mitral

PREGUNTA 16 1.05.1.005, 4.01.1.013

**16. Una mujer de 29 años, con diagnóstico de hipotiroidismo primario en tratamiento estable con levotiroxina 75 mcg al día y TSH reciente de 1.8 mIU/L, acude a la consulta médica confirmando que tiene 5 semanas de amenorrea y un test de embarazo en orina positivo. ¿Cuál es la indicación médica inmediata más adecuada respecto a su terapia hormonal?**

A) Suspender la levotiroxina durante el primer trimestre por riesgo teratogénico fetal
B) Mantener la dosis de 75 mcg/día sin cambios hasta el parto dado que la última TSH estaba normal
C) Incrementar de inmediato la dosis de levotiroxina en un 25 a 30% (por ejemplo, agregando dos comprimidos semanales) y controlar TSH en 4 semanas
D) Cambiar la levotiroxina por propiltiouracilo durante el primer trimestre
E) Reducir la dosis a la mitad para evitar inducir hipertiroidismo fetal

PREGUNTA 17 1.05.1.005, 4.01.1.013

**17. ¿Cuál es el momento óptimo para la toma de la muestra de sangre en papel filtro para el tamizaje neonatal universal de hipotiroidismo congénito en Chile según la norma del Ministerio de Salud?**

A) En sangre de cordón umbilical inmediatamente al momento del alumbramiento
B) En las primeras 6 horas de vida
C) Entre las 40 y 48 horas de vida, antes del alta de la maternidad
D) A los 7 días de vida en el primer control ambulatorio del recién nacido
E) Al mes de vida en el control de salud de la díada

PREGUNTA 18 1.03.2.004

**18. Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. ¿Cuál es el tratamiento inicial de urgencia?**

A) Resonancia magnética
B) Cintigrafía con sestamibi (localización de adenoma paratiroideo)
C) Hidratación EV con solución salina 0.9%
D) Paratiroidectomía de urgencia
E) Carbonato de calcio oral

## BLOQUE 2 · BLOQUE 2 · TIROTOXICOSIS, BOCIO, NÓDULO Y CÁNCER DE TIROIDES

PREGUNTA 19 1.03.1.003

**19. Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Enfermedad de Graves-Basedow
B) Tiroiditis de Hashimoto
C) Bocio multinodular tóxico
D) Adenoma tóxico de tiroides
E) Tiroiditis subaguda de De Quervain

PREGUNTA 20 1.03.1.001

**20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Bocio · 1.03.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bocio. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 1.03.1.004

**21. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del tiroides · 1.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 22 1.04.1.002

**22. Una mujer de 32 años con diagnóstico de Enfermedad de Graves-Basedow inicia tratamiento con tiamazol 20 mg al día y propranolol 40 mg cada 8 horas. A las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento, consulta en el servicio de urgencias por un cuadro de 24 horas de fiebre de 38.9°C, calofríos intensos y dolor faríngeo severo. Al examen físico se aprecia faringe congestiva con exudado amigdalino blanquecino y FC de 102 lpm. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e inaplazable?**

A) Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral y citar a control en 48 horas
B) Suspender de inmediato el tiamazol, solicitar un hemograma urgente con recuento diferencial absoluto y hospitalizar en aislamiento
C) Duplicar la dosis de tiamazol a 40 mg/día por sospecha de reactivación tiroidea
D) Cambiar el tiamazol por propiltiouracilo a dosis equivalentes
E) Indicar paracetamol 1 g cada 8 horas y continuar el tiamazol sin modificaciones

PREGUNTA 23 1.04.1.002

**23. Una paciente de 26 años con antecedente de Enfermedad de Graves-Basedow bien controlada con tiamazol 10 mg/día acude a control preconcepcional. Al examen se constata un bocio difuso indoloro sin signos inflamatorios. Su prueba de embarazo en orina resulta positiva, estimándose una gestación de 5 semanas. Su perfil hormonal muestra TSH 0.8 mIU/L y T4 libre 1.3 ng/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su terapia antitiroidea durante este período?**

A) Mantener el tiamazol a la misma dosis durante todo el embarazo por encontrarse eutiroidea
B) Suspender el tiamazol y cambiar inmediatamente a propiltiouracilo (PTU) a dosis equivalentes durante el primer trimestre
C) Suspender todos los antitiroideos y administrar de inmediato una dosis terapéutica de radioyodo I-131
D) Indicar tiroidectomía total de urgencia durante la semana 6 de gestación
E) Suspender todo tratamiento farmacológico y mantener únicamente observación sin controles hormonales

PREGUNTA 24 1.04.1.002

**24. Un hombre de 68 años con antecedente de insuficiencia cardíaca consulta por palpitaciones de reposo, baja de 4 kg de peso en un mes y astenia. El electrocardiograma revela una fibrilación auricular de novo con respuesta ventricular de 135 lpm. La ecografía cervical no muestra nódulos ni bocio evidente y el examen oftalmológico es rigurosamente normal. Los exámenes revelan TSH < 0.01 mIU/L con T4 libre de 2.6 ng/dL. Los anticuerpos TRAb son negativos. El cintigrama tiroideo muestra captación focalizada e intensa en el polo inferior derecho con supresión funcional completa del resto del parénquima tiroideo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tiroiditis subaguda de De Quervain
B) Enfermedad de Graves-Basedow con variante atípica
C) Adenoma tóxico autónomo (enfermedad de Plummer unilocular)
D) Cáncer folicular de tiroides hiperfuncionante
E) Tirotoxicosis facticia por ingesta oculta de hormona tiroidea

PREGUNTA 25 1.04.1.002

**25.** **Una mujer de 35 años con Enfermedad de Graves-Basedow presenta recaída clínica y bioquímica tras haber completado 18 meses de terapia con tiamazol. Al examen físico destaca proptosis ocular moderada bilateral, quemosis conjuntival y diplopía al mirar hacia arriba, con test de actividad clínica orbitaria (CAS) de 4 puntos (enfermedad activa). Se plantea ablación tiroidea definitiva. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada para el manejo definitivo de su hipertiroidismo?**

A) Administrar dosis ablativa de radioyodo I-131 en monoterapia ambulatoria sin medicación previa

B) Tiroidectomía total previa preparación con tiamazol y yoduro inorgánico (Lugol), o en su defecto I-131 bajo estricta corticoterapia profiláctica sistémica

C) Suspender todo antitiroideo y manejar exclusivamente con propranolol oral

D) Indicar radioterapia orbitaria externa inmediata sin tocar la glándula tiroidea

E) Mantener tiamazol a dosis de 60 mg/día de por vida sin plantear terapia ablativa

PREGUNTA 26 1.04.1.002

**26.** **Una paciente de 42 años con antecedente de bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, consulta para definir tratamiento curativo. La paciente tiene paridad completa y no tiene deseos de futuros embarazos. Se le propone tratamiento ablativo con radioyodo I-131. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta terapia es correcta?**

A) La probabilidad de remisión completa sin requerir levotiroxina es superior al 95%

B) El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, el cual requiere suplementación de por vida

C) La paciente puede amamantar sin restricciones a su hijo lactante de 8 meses el día posterior al radioyodo

D) El I-131 está contraindicado porque los bocios multinodulares responden exclusivamente a tiamazol de por vida

E) El fármaco debe asociarse a dosis altas de aspirina para potenciar la fijación del isótopo

PREGUNTA 27 1.04.1.002

**27.** **Un paciente de 38 años con Enfermedad de Graves y un bocio difuso masivo de 120 gramos con compresión traqueal sintomática será sometido a una tiroidectomía total programada. Se encuentra actualmente eutiroideo bajo tratamiento con tiamazol 20 mg/día. Para minimizar el sangrado operatorio y reducir la vascularización de la glándula durante el acto quirúrgico, ¿cuál es la medida farmacológica preoperatoria recomendada en los 7 a 10 días previos a la cirugía?**

A) Indicar solución de Lugol (yoduro inorgánico) oral 3 a 5 gotas cada 8 horas

B) Suspender el tiamazol e iniciar propiltiouracilo a dosis altas

C) Administrar una dosis baja de radioyodo I-131 48 horas antes de la incisión

D) Indicar anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular

E) Administrar carbonato de litio para aumentar la captación de hormonas

PREGUNTA 28 1.03.2.001

**28.** **[URGENCIA: Tormenta tiroidea · 1.03.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Tormenta tiroidea. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 29 1.04.1.002

**29.** **Una mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en el servicio de urgencias por fiebre de 39.5°C, agitación psicomotora, náuseas, vómitos profusos y palpitaciones taquicárdicas. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal a 145 lpm y la escala de Burch-Wartofsky arroja 60 puntos, confirmando una tormenta tiroidea. ¿Cuál de las siguientes secuencias y combinaciones de fármacos representa el manejo médico correcto?**

A) Administrar ácido acetilsalicílico 1 g EV de inmediato, seguido de tiamazol 10 mg oral

B) Iniciar propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona endovenosa y posponer la solución de Lugol para administrarla al menos una hora después del propiltiouracilo

C) Administrar solución de Lugol en bolo endovenoso inmediato y continuar con levotiroxina en infusión

D) Indicar tiroidectomía total de urgencia en los primeros 30 minutos sin administración previa de fármacos

E) Administrar radioyodo I-131 a dosis máxima como terapia ablativa urgente

PREGUNTA 30 1.04.1.002

**30.** **En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia severa de 40.2°C y compromiso sensorial en la unidad de cuidados intensivos, el residente de turno planea indicar un antipirético. ¿Cuál de los siguientes fármacos antipiréticos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO por el riesgo inminente de incrementar las concentraciones plasmáticas de hormona tiroidea libre?**

A) Paracetamol

B) Dipirona (Metamizol)

C) Ácido acetilsalicílico (Aspirina)

D) Ibuprofeno

E) Ketorolaco

PREGUNTA 31 1.04.1.002

**31. Un hombre de 45 años con antecedente de Enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con cuadro de shock distributivo, agitación extrema, diaforesis, ictericia y fibrilación auricular rápida a 160 lpm. Se diagnostica tormenta tiroidea con escala de Burch-Wartofsky de 65 puntos. ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico fundamental por el cual se debe administrar Hidrocortisona endovenosa en el esquema inicial de rescate?**

A) Para tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por incremento acelerado del metabolismo del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3
B) Para inducir inmunosupresión inmediata de los anticuerpos TRAb en menos de 2 horas
C) Para elevar la TSH hipofisaria y restablecer el asa de retroalimentación
D) Para favorecer la captación folicular de yodo inorgánico
E) Para evitar la hipoglicemia provocada por el propiltiouracilo

PREGUNTA 32 1.04.1.002

**32. En el protocolo de reanimación de la tormenta tiroidea, el orden cronológico de administración de los medicamentos es un aspecto técnico de máxima relevancia evaluado en EUNACOM. ¿Cuál es la razón biológica por la que se debe administrar el antitiroideo (propiltiouracilo) AL MENOS 60 minutos antes de administrar el yodo inorgánico (Lugol)?**

A) Para evitar una reacción anafiláctica alérgica al yodo mediada por IgE
B) Para impedir que el yoduro exógeno sea utilizado como sustrato folicular para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas (Fenómeno de Jod-Basedow)
C) Porque el yodo inorgánico inactiva químicamente al propiltiouracilo en la luz gástrica
D) Para asegurar la absorción duodenal previa del propranolol
E) Para prevenir la nefropatía por contraste inducida por tionamidas

PREGUNTA 33 1.03.1.021

**33. Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cintigrafía tiroidea
B) Realizar punción con aguja fina
C) Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
D) Solicitar niveles de tiroglobulina
E) Realizar cirugía

PREGUNTA 34 1.04.1.003

**34. Un hombre de 49 años se realiza un chequeo médico de medicina preventiva en el cual se pesquisa un nódulo tiroideo palpable de 1.8 cm en el polo inferior izquierdo. La TSH resulta en 2.1 mIU/L. La ecografía cervical informa un nódulo sólido, marcadamente hipoecogénico de 18 mm, con microcalcificaciones en su espesor y márgenes microlobulados, catalogado como ACR TI-RADS 5. No se identifican adenopatías patológicas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada a seguir?**

A) Solicitar un cintigrama tiroideo con Tecnecio-99m para evaluar captación
B) Indicar Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía
C) Iniciar tratamiento supresor con levotiroxina 100 mcg/día para reducir el tamaño del nódulo
D) Indicar control ecográfico en 12 meses sin realizar biopsia
E) Administrar una dosis empírica de radioyodo I-131

PREGUNTA 35 1.04.1.003

**35. Una mujer de 52 años consulta por un nódulo tiroideo solitario de 2.2 cm en el lóbulo derecho. Se solicita TSH que resulta en 0.05 mIU/L (suprimida) y T4 libre en 1.9 ng/dL. La paciente se encuentra oligoasintomática, con pulso de 88 lpm regular. ¿Cuál es el examen complementario de elección que debe realizarse a continuación para definir la conducta?**

A) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de inmediato
B) Resonancia magnética de cuello con contraste paramagnético
C) Cintigrama tiroideo con I-131 o Tc-99m
D) Determinación seriada de calcitonina sérica
E) Tomografía computarizada de tórax y cuello

PREGUNTA 36 1.04.1.003

**36. Un paciente de 39 años es sometido a una PAAF guiada por ecografía de un nódulo tiroideo de 2.0 cm clasificado previamente como TI-RADS 4. El informe de la citopatología concluye: "Categoría Bethesda IV: Neoplasia Folicular / Sospecha de Neoplasia Folicular". El paciente no tiene antecedentes familiares ni factores de riesgo adicionales. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección indicada en este caso?**

A) Observación clínica con ecografía de control a los 6 meses
B) Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica con estudio histopatológico definitivo diferido
C) Tiroidectomía total inmediata más vaciamiento ganglionar cervical radical bilateral
D) Tratamiento con radioyodo I-131 ambulatorio a dosis ablativa
E) Repetir la PAAF inmediatamente con aguja de mayor calibre (tru-cut)

## BLOQUE 3 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA

PREGUNTA 37 1.03.1.008

**37. Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?**

A) Relación FSH/LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Prolactina
E) 17-hidroxi-progesterona

PREGUNTA 38 1.03.1.006

**38. Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino
B) 17 hidroxiprogesterona
C) TAC de silla turca
D) Cortisol libre urinario de 24 horas
E) Prueba de estimulación con ACTH

PREGUNTA 39 1.03.1.022

**39. [ATENCIÓN PRIMARIA: Incidentaloma suprarrenal · 1.03.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Incidentaloma suprarrenal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 40 1.04.1.005

**40. Una mujer de 35 años consulta por obesidad central, debilidad muscular proximal, amenorrea de 6 meses y aparición de estrías violáceas anchas en abdomen. No refiere uso de fármacos. Se solicita un test de Nugent (1 mg dexametasona a las 23 h) que muestra cortisol matinal de 9.8 mcg/dL (no suprime) y un cortisol libre urinario en 24 horas elevado a 350 mcg (normal < 50 mcg/24h). ¿Cuál es el examen de elección que se debe solicitar a continuación para proseguir con el estudio etiológico?**

A) Tomografía computarizada de abdomen y pelvis con protocolo suprarrenal
B) Determinación de niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropa (ACTH)
C) Resonancia magnética de silla turca con contraste
D) Cateterismo de senos petrosos inferiores
E) Cintigrama con octreótido marcado

PREGUNTA 41 1.04.1.005

**41. Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta en urgencias por astenia severa, debilidad muscular profunda que le impide la bipedestación, edema de extremidades inferiores y pérdida de 8 kg de peso en el último mes. Al examen físico destaca hiperpigmentación cutánea difusa en zonas fotoexpuestas y pliegues, PA 175/105 mmHg, sin obesidad evidente. Los exámenes de laboratorio revelan glicemia de 260 mg/dL, sodio 144 mEq/L, potasio 2.1 mEq/L y bicarbonato de 36 mEq/L (alcalosis metabólica hipokalémica). Se confirma hipercortisolismo con ACTH plasmática marcadamente elevada en 280 pg/mL. El test de supresión con dosis alta de dexametasona (8 mg) no muestra supresión del cortisol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario
B) Carcinoma de la corteza suprarrenal productor de cortisol
C) Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)
D) Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)
E) Insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis

PREGUNTA 42 1.04.1.005

**42. Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC de abdomen revela un tumor suprarrenal derecho de 3.2 cm homogéneo con baja atenuación (< 10 Unidades Hounsfield) compatible con adenoma benigno; la glándula suprarrenal izquierda luce de aspecto atrófico y delgada. La paciente es sometida exitosamente a una suprarrenalectomía laparoscópica derecha. En el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la medida farmacológica mandatoria que debe iniciarse para prevenir una complicación potencialmente mortal?**

A) Iniciar ketoconazol oral para bloquear residuos tumorales
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral
C) Indicar espironolactona a dosis altas para prevenir hiperkalemia
D) Indicar radioyodo I-131 para destruir remanentes glandulares
E) Mantener en observación sin medicamentos puesto que la glándula contralateral asumirá de inmediato la función fisiológica

PREGUNTA 43 1.04.1.005

**43. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de pruebas de laboratorio es la más apropiada y aceptada por el consenso internacional como PRIMERA LÍNEA para pesquisar y confirmar la presencia de hipercortisolismo endógeno en un paciente con sospecha clínica de Síndrome de Cushing?**

A) Cortisol plasmático basal a las 08:00 h y ACTH plasmática basal
B) Test de supresión rápida con dexametasona 1 mg nocturno (Nugent), Cortisol Libre Urinario en 24 horas y Cortisol salival nocturno
C) Test de dexametasona 8 mg y Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales
D) Medición de metabolitos urinarios 17-hidroxicorticosteroides y 17-cetosteroides
E) Test de estimulación con ACTH sintética (Synacthen) 250 mcg

PREGUNTA 44 1.03.1.007

**44.** **Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome paraneoplásico
B) Desnutrición proteica
C) Enfermedad de Addison
D) Cáncer de sitio no precisado
E) Pancreatitis crónica

PREGUNTA 45 1.03.1.019

**45.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Osteoporosis secundaria · 1.03.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Osteoporosis secundaria. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 46 1.03.2.003

**46.** **Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na+: 126 mEq/L, K+: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm3, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Insuficiencia renal aguda
B) Shigelosis
C) Peritonitis aguda
D) Insuficiencia suprarrenal aguda
E) Accidente vascular hemorrágico

PREGUNTA 47 1.04.1.006

**47.** **Un hombre de 42 años acude a la consulta médica por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e hipotensión arterial. Al examen físico destaca hiperpigmentación marcada en surcos de las manos, codos y encías. Sus exámenes demuestran Na+ 129 mEq/L, K+ 5.8 mEq/L y glicemia de 70 mg/dL. El cortisol basal a las 08:00 h resulta en 2.0 mcg/dL con ACTH plasmática de 180 pg/mL (VN < 50). ¿Cuál es el tratamiento sustitutivo crónico de elección que debe prescribirse?**

A) Hidrocortisona oral en monoterapia
B) Prednisona oral asociada a espironolactona
C) Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral
D) Dexametasona oral en dosis nocturna única
E) Fludrocortisona oral en monoterapia sin glucocorticoides

PREGUNTA 48 1.04.1.006

**48.** **Una mujer de 58 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento crónico con prednisona 15 mg diarios durante 2 años decide suspender bruscamente el fármaco por cuenta propia. A los 5 días consulta en el policlínico por debilidad extrema, náuseas, astenia e hipotensión postural (PA 95/60 mmHg). Se constata piel pálida sin hiperpigmentación. El laboratorio muestra Na+ 131 mEq/L, K+ 4.2 mEq/L, ACTH de 4 pg/mL y cortisol de 2.1 mcg/dL. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que explica este cuadro?**

A) Destrucción autoinmune aguda de la glándula suprarrenal
B) Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada
C) Falla mineralocorticoide primaria con pérdida renal masiva de potasio
D) Secreción ectópica de péptidos suresores adrenales
E) Síndrome de lisis corticosuprarrenal por nefropatía intersticial

PREGUNTA 49 1.04.1.006

**49.** **Un paciente de 45 años con antecedente de Enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona presenta neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Ingresa a la urgencia estuporoso, pálido, sudoroso, con PA 65/40 mmHg y FC 128 lpm. El hemoglucotest marca 52 mg/dL. Tras recibir 2000 mL de suero fisiológico en 45 minutos, la presión arterial se mantiene en 70/45 mmHg. ¿Cuál es la medida farmacológica inmediata de máxima prioridad para revertir este estado hemodinámico?**

A) Iniciar infusión de dopamina a dosis inotrópica
B) Iniciar infusión continua de noradrenalina a dosis altas
C) Administrar Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso directo
D) Administrar fludrocortisona 1 mg por sonda nasogástrica
E) Realizar pericardiocentesis de urgencia

PREGUNTA 50 1.04.1.006

**50. Un lactante de 2 semanas de vida es traído a urgencias en estado de shock severo, deshidratación grave, letargia y vómitos explosivos. El ionograma plasmático urgente revela Na+ 118 mEq/L y K+ 7.8 mEq/L con acidosis metabólica severa. Al examen físico destaca hiperpigmentación de los genitales externos y escroto rugoso hiperpigmentado. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica prioritaria y el tratamiento médico urgente que debe instaurarse sin demora?**

A) Estenosis hipertrófica del píloro; resolución quirúrgica de urgencia
B) Hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal (déficit de 21-hidroxilasa); rescate urgente con Hidrocortisona endovenosa y solución salina fisiológica
C) Sepsis por Pseudomonas aeruginosa; ceftazidima en bolo
D) Insuficiencia renal aguda anúrica; hemodiálisis de emergencia
E) Síndrome urémico hemolítico; transfusión de glóbulos rojos lavados

PREGUNTA 51 1.04.1.006

**51. En un servicio de urgencias ingresa un paciente con alta sospecha de crisis suprarrenal aguda en shock hipotensivo. El médico de turno solicita una muestra de sangre para cortisol y electrolitos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al inicio de la Hidrocortisona endovenosa?**

A) Esperar el resultado analítico del cortisol plasmático en sangre para confirmar el diagnóstico antes de inyectar el corticoide
B) Extraer la muestra de sangre e iniciar INMEDIATAMENTE el bolo de Hidrocortisona 100 mg EV sin esperar el resultado del laboratorio
C) Esperar la realización de una ecografía suprarrenal previa para descartar hemorragia adrenal
D) Iniciar antibióticos de amplio espectro y diferir los corticoides hasta las 12 horas de evolución
E) Administrar solución salina exclusiva y esperar 6 horas de respuesta hemodinámica

PREGUNTA 52 1.04.1.006

**52. ¿Por qué razón farmacológica y fisiológica NO es necesario administrar Fludrocortisona (mineralocorticoide) durante la fase aguda de reanimación en una crisis suprarrenal manejada con Hidrocortisona a dosis altas (100 mg cada 6 a 8 horas)?**

A) Porque la fludrocortisona solo se absorbe por vía rectal
B) Porque a dosis iguales o superiores a 50-100 mg/día, la hidrocortisona satura el receptor mineralocorticoide proporcionando una actividad mineralocorticoide plenamente suficiente
C) Porque la aldosterona se encuentra siempre elevada en la crisis suprarrenal
D) Porque la fludrocortisona empeora la hipoglicemia aguda
E) Porque los mineralocorticoides están contraindicados si la presión arterial sistólica es menor a 90 mmHg

PREGUNTA 53 1.04.1.007

**53. Un hombre de 34 años con diagnóstico reciente de hipertensión arterial severa (PA 170/110 mmHg) presenta debilidad muscular episódica y calambres. En los exámenes de laboratorio se constata hipokalemia de 2.9 mEq/L sin uso previo de diuréticos. Se sospecha hiperaldosteronismo primario. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A) Determinación de cortisol libre urinario en 24 horas
B) Medición simultánea de la relación aldosterona plasmática / actividad de renina plasmática (RAR)
C) Tomografía computarizada de glándulas suprarrenales con contraste
D) Angiografía de arterias renales
E) Metanefrinas libres en plasma

PREGUNTA 54 1.04.1.007

**54. Una paciente de 48 años con hipertensión arterial de difícil manejo y relación aldosterona/renina elevada es sometida a un estudio etiológico completo que demuestra una Hiperplasia Suprarrenal Bilateral Idiopática. No es candidata a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento médico farmacológico de primera elección para controlar su hipertensión y normalizar el potasio sérico?**

A) Suprarrenalectomía bilateral total inmediata
B) Espironolactona oral
C) Furosemida en dosis altas
D) Aliskiren (inhibidor directo de la renina)
E) Hidralazina asociada a minoxidil

## BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO

PREGUNTA 55 1.03.1.020

**55. Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día) . El diagnóstico más probable es:**

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo secundario
C) Hiperparatiroidismo terciario
D) Hipercalciuria primaria
E) Hipercalciuria familiar

PREGUNTA 56 1.03.1.020

**56. En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN: ) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipercalcemia idiopática
B) Hiperparatiroidismo primario
C) Hiperparatiroidismo secundario
D) Hiperparatiroidismo terciario
E) Hipercalcemia familiar

PREGUNTA 57 1.03.1.020

**57. Mujer de 58 años con calcio sérico de 11.8 mg/dL detectado en examen de rutina. Asintomática. Sin uso de suplementos de calcio ni vitamina D. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para determinar la causa de la hipercalcemia?**

A) PTH sérica
B) Fósforo sérico
C) Calcitonina
D) Calcio en orina de 24h
E) Vitamina D (25-OH)

PREGUNTA 58 1.03.1.020

**58. Hombre de 55 años asintomático con calcio sérico 11.2 mg/dL, fósforo 2.1 mg/dL (bajo) y PTH 145 pg/mL (elevada). Sin otros hallazgos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
C) Hipercalcemia de malignidad
D) Intoxicación por vitamina D
E) Sarcoidosis

PREGUNTA 59 1.03.1.020

**59. Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?**

A) Cintigrafía ósea
B) Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Niveles plasmáticos de vitamina D
E) Resonancia magnética de abdomen y pelvis

PREGUNTA 60 1.03.1.020

**60. Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A) Calciuria de 24 horas
B) Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
C) Niveles plasmáticos de paratohormona
D) Cintigrafía ósea
E) Niveles plasmáticos de calcio iónico

PREGUNTA 61 1.03.2.005

**61. Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Calcitriol oral más calcio oral
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Carbonato de calcio 1 g oral
D) PTH recombinante subcutáneo
E) Terlipresina endovenosa

PREGUNTA 62 1.04.1.009

**62. Un paciente de 64 años con antecedente de cáncer epidermoide de pulmón en etapa avanzada ingresa al servicio de urgencias estuporoso, con sequedad extrema de mucosas, deshidratación severa y signos clínicos de shock hipovolémico. El laboratorio de urgencia revela: Calcio plasmático de 15.2 mg/dL con albúmina de 3.0 g/dL (calcio corregido de 16.0 mg/dL), creatinina de 2.8 mg/dL y una PTH intacta suprimida en 4 pg/mL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT marcadamente acortado. ¿Cuál es la primera medida terapéutica de máxima prioridad que debe iniciarse de inmediato?**

A) Infusión endovenosa rápida de furosemida a dosis de 80 mg en bolo
B) Hidratación agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% en infusión endovenosa continua de 200 a 300 mL/hora
C) Calcitonina de salmón subcutánea en monoterapia
D) Ácido zoledrónico 4 mg EV en bolo rápido sin hidratación previa
E) Fosfato de potasio endovenoso

PREGUNTA 63 1.04.1.009

**63. Una paciente de 46 años asintomática acude a control de salud. En un perfil bioquímico preventivo se detecta calcio sérico de 11.2 mg/dL con albúmina de 4.0 g/dL. El médico sospecha hiperparatiroidismo primario. ¿Cuál es el examen de laboratorio indispensable que confirmará esta sospecha diagnóstica al demostrar su valor elevado o inapropiadamente normal?**

A) Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi)
B) Péptido relacionado con la PTH (PTHrP)
C) Calcitriol sérico (1,25-dihidroxivitamina D)
D) Calcitonina plasmática
E) Fosfatasas alcalinas óseas

PREGUNTA 64 1.04.1.009

**64. Una mujer de 44 años asintomática presenta hiperparatiroidismo primario confirmado con calcio corregido de 11.8 mg/dL y PTHi de 110 pg/mL. La densitometría ósea muestra un T-score de -2.7 en columna lumbar y la ecografía renal pesquisó microlitiasis renal asintomática. La paciente consulta si debe intervenirse quirúrgicamente. ¿Cuál es la indicación médica correcta respecto a la cirugía paratiroidea?**

A) No cumple criterios quirúrgicos por encontrarse asintomática; mantener control anual exclusivo con densitometría
B) Cumple criterios formales de Paratiroidectomía debido a su edad menor de 50 años, nivel de calcio > 1 mg/dL sobre el límite normal, presencia de osteoporosis (T-score < -2.5) y litiasis renal
C) Debe recibir radioterapia cervical externa en lugar de cirugía
D) Debe indicarse tratamiento de por vida con cinacalcet y suspender todo lácteo
E) La cirugía está contraindicada porque los adenomas paratiroideos regresionan espontáneamente

PREGUNTA 65 1.04.1.009

**65. Un paciente de 52 años sometido a una paratiroidectomía subtotal exitosa por hiperparatiroidismo primario severo con compromiso óseo extenso presenta al tercer día postoperatorio parestesias periorales intensas, signo de Chvostek positivo, espasmo carpopedal (signo de Trousseau) y calcio plasmático de 6.4 mg/dL con fósforo sérico de 1.8 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación postquirúrgica clásica?**

A) Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome)
B) Hipotiroidismo iatrogénico agudo
C) Falla renal aguda por nefropatía de contraste
D) Pseudohipoparatiroidismo tipo 1A
E) Crisis tirotóxica por manipulación cervical

PREGUNTA 66 1.04.1.010

**66. Una paciente de 42 años intervenida de tiroidectomía total hace 48 horas presenta parestesias periorales, contractura muscular dolorosa en ambas manos al inflar el manguito de presión arterial (signo de Trousseau positivo) y sensación de falta de aire con estridor inspiratorio leve. El laboratorio urgente confirma un calcio plasmático de 6.1 mg/dL. ¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata más adecuada?**

A) Administrar carbonato de calcio 1 g por vía oral y citar a control en 24 horas
B) Administrar una ampolla de Gluconato de Calcio al 10% por vía endovenosa lenta en 10 a 20 minutos bajo monitorización cardíaca
C) Administrar vitamina D3 (colecalciferol) 100.000 UI en dosis oral única
D) Indicar rebreathing con bolsa de papel para aumentar la pCO2
E) Administrar cloruro de potasio en bolo endovenoso rápido

PREGUNTA 67 1.04.1.010

**67. Un paciente alcohólico crónico de 54 años ingresa desnutrido con tetania muscular y parestesias. El calcio sérico es de 6.8 mg/dL. Pese a recibir dos bolos endovenosos consecutivos de gluconato de calcio, el paciente persiste tetánico con calcio sérico en 6.9 mg/dL. ¿Cuál es el examen de laboratorio que debe solicitarse de inmediato para identificar la causa de la refractariedad terapéutica?**

A) Magnesemia plasmática
B) Calcitonina sérica
C) TSH sérica
D) Ácido fólico plasmático
E) Plomo en sangre

PREGUNTA 68 1.03.1.018

**68. Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar ejercicio aeróbico
B) Indicar reposo relativo
C) Aumentar dosis de vitamina D y calcio
D) Agregar bifosfonatos al tratamiento
E) Mantener el tratamiento

PREGUNTA 69 1.04.1.011

**69. Una mujer de 71 años presenta una fractura del cuello femoral izquierdo tras resbalar y caer desde su propia altura en el living de su casa. En el postoperatorio de la osteosíntesis, la densitometría ósea informa un T-score de -2.2 DE en columna lumbar y -2.1 DE en cadera contralateral (osteopenia). ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a su salud ósea?**

A) No iniciar fármacos antiosteoporóticos específicos debido a que el T-score no alcanza el umbral de -2.5 DE
B) Iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico con bifosfonatos (o ácido zoledrónico) asociado a calcio y vitamina D, debido a que la fractura por fragilidad establece el diagnóstico clínico directo de osteoporosis
C) Indicar reposo absoluto en cama por 6 meses para favorecer la consolidación ósea
D) Administrar calcitonina nasal como único tratamiento durante 5 años
E) Citar a nueva densitometría en 2 años para reevaluar la indicación de fármacos

PREGUNTA 70 1.04.1.011

**70. Una paciente de 66 años con osteoporosis densitométrica (T-score -2.9 en columna lumbar) inicia tratamiento con Alendronato 70 mg una vez a la semana por vía oral. Para maximizar la absorción del medicamento y minimizar el riesgo de esofagitis erosiva medicamentosa severa, ¿cuál de las siguientes indicaciones de administración debe entregarse a la paciente?**

A) Ingerir el comprimido por la noche inmediatamente antes de acostarse junto a un vaso de leche entera
B) Tomar el comprimido en ayuno absoluto matinal con un vaso lleno de agua pura de la llave y mantenerse sentada o de pie sin acostarse durante al menos 30 minutos
C) Masticar el comprimido junto con el desayuno matinal para facilitar su deglución
D) Disolver el comprimido en jugo de naranja cítrico para favorecer su solubilidad ácida
E) Tomar el comprimido junto a las sales de calcio para que se absorban de manera conjunta

PREGUNTA 71 1.04.1.012

**71. Un médico de atención primaria atiende a una mujer de 82 años institucionalizada en un hogar de ancianos sin exposición a luz solar. Para evaluar el estado de sus reservas corporales de vitamina D y descartar deficiencia nutricional, ¿cuál es el examen de laboratorio específico que debe solicitarse?**

A) 1,25-dihidroxivitamina D sérica (Calcitriol)
B) 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o Calcidiol]
C) Calcitonina sérica basal
D) Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)
E) Fosfatasas alcalinas leucocitarias

PREGUNTA 72 1.04.1.012

**72.** **Una paciente de 75 años con dolor óseo sordo progresivo y debilidad muscular proximal presenta en sus exámenes de sangre: Calcio 8.5 mg/dL, Fósforo 2.0 mg/dL, Fosfatasas Alcalinas elevadas en 380 U/L (VN < 120), PTH intacta de 120 pg/mL y una 25-hidroxivitamina D de 7 ng/mL. Las radiografías revelan seudofracturas en ramas isquiopubianas. Se concluye Osteomalacia por déficit severo de vitamina D. ¿Cuál es el esquema farmacológico de ataque más apropiado?**

A) Colecalciferol 50.000 UI por vía oral una vez a la semana durante 8 semanas, asociado a suplementación con calcio elemental
B) Ácido zoledrónico 5 mg endovenoso en dosis única
C) Alendronato 70 mg semanal en monoterapia
D) Teriparatida 20 mcg subcutáneo diario sin vitamina D
E) Calcitonina nasal 200 UI diarias

## BLOQUE 5 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN

PREGUNTA 73 1.03.1.010

**73.** **Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:**

A) Prolactinoma
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

PREGUNTA 74 1.03.1.012

**74.** **Un paciente de 32 años consulta por un cuadro de disfunción sexual asociado a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución del tamaño testicular bilateral. ¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?**

A) Prolactina
B) Testosterona y LH
C) Espermiograma y FSH
D) Ecografía testicular
E) HCG y estradiol

PREGUNTA 75 1.03.1.023

**75.** **Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. Sin medicamentos. Desarrollo puberal Tanner 3. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta?**

A) Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar
B) Cáncer de mama masculino; biopsia urgente
C) Hiperprolactinemia; solicitar prolactina
D) Hipogonadismo; solicitar testosterona
E) Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

PREGUNTA 76 1.03.1.009

**76.** **Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:**

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo
E) Hipertensión esencial

PREGUNTA 77 1.03.1.013

**77.** **Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?**

A) Niveles de hormona de crecimiento
B) Radiografías de pies y de la arcada dentaria
C) Radiografía de manos
D) Niveles de IGF-1
E) Resonancia magnética de hipófisis

PREGUNTA 78 1.04.1.013

**78.** **Un paciente de 52 años consulta por cefalea progresiva. La campimetría visual computarizada demuestra una hemianopsia bitemporal. La RM de cerebro revela una masa intraselar con extensión supraselar de 24 mm que comprime el quiasma óptico. El perfil hormonal descarta hiperprolactinemia (prolactina normal) y no hay hipersecreción de GH ni ACTH. ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado para descomprimir la vía óptica y evitar la ceguera permanente?**

A) Iniciar cabergolina oral a dosis altas
B) Cirugía de resección transesfenoidal del macroadenoma
C) Radioterapia holocraneana convencional
D) Tratamiento con temozolomida
E) Observación con control campimétrico en 6 meses

PREGUNTA 79 1.04.1.013

**79.** **Un hombre de 45 años con antecedente de cefaleas esporádicas consulta en el servicio de urgencias por inicio súbito hace 3 horas de cefalea holocraneana de intensidad 10/10 en 'estallido', acompañada de vómitos, caída del párpado superior derecho (ptosis palpebral), diplopía y marcada somnolencia. Al examen físico destaca PA 85/50 mmHg, FC 62 lpm, parálisis completa del tercer par craneal derecho con midriasis y defecto campimétrico bitemporal severo. La TC de cerebro muestra una masa selar heterogénea con focos hiperdensos compatibles con hemorragia aguda intraselar. ¿Cuál es la medida médica farmacológica inicial de máxima prioridad que debe administrarse de inmediato?**

A) Manitol al 20% en infusión rápida
B) Hidrocortisona 100 mg endovenosa directa en bolo
C) Cabergolina por sonda nasogástrica
D) Heparina de bajo peso molecular subcutánea
E) Somatostatina endovenosa continua

PREGUNTA 80 1.03.1.016

**80.** **Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimir las mamas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar niveles de progesterona
B) Solicitar niveles de prolactina
C) Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

PREGUNTA 81 1.04.1.014

**81.** **Una paciente de 28 años consulta por amenorrea de 6 meses y galactorrea bilateral. La prueba de embarazo es negativa y la TSH es de 1.9 mIU/L. La prolactina sérica resulta en 180 ng/mL. La RM de cerebro confirma un prolactinoma de 8 mm intraselar. La paciente no toma medicamentos y desea recuperar sus ciclos menstruales para buscar un embarazo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección que debe indicarse?**

A) Resección quirúrgica por vía transesfenoidal de inmediato
B) Terapia médica oral con Cabergolina (agonista dopaminérgico)
C) Radiocirugía estereotáxica con Gamma Knife
D) Anticonceptivos orales combinados para inducir sangrado
E) Reemplazo con levotiroxina en dosis supresiva

PREGUNTA 82 1.04.1.014

**82.** **Una paciente de 34 años con antecedente de esquizofrenia en tratamiento regular con risperidona 4 mg al día desde hace un año consulta por ausencia de menstruaciones de 4 meses y galactorrea bilateral leve. No presenta cefalea ni alteraciones visuales. La prueba de embarazo es negativa. La prolactina plasmática resulta en 58 ng/mL y la TSH es normal. ¿Cuál es la causa más probable de su hiperprolactinemia y amenorrea?**

A) Macroprolactinoma hipofisario invasor
B) Efecto adverso farmacológico por bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 en la vía tuberoinfundibular inducido por risperidona
C) Insuficiencia ovárica primaria autoinmune precoz
D) Síndrome de Sheehan asintomático
E) Carcinoma corticosuprarrenal ectópico

PREGUNTA 83 1.04.1.015

**83.** **Un paciente de 48 años consulta por sudoración profusa, ensanchamiento progresivo de manos y pies y síndrome de apnea obstructiva del sueño. El médico sospecha acromegalia. ¿Cuál es el examen de tamizaje de primera línea que debe solicitarse para evaluar la presencia de esta patología?**

A) Determinación aislada de hormona de crecimiento (GH) plasmática matinal en ayunas
B) Factor de crecimiento insulínico tipo 1 sérico (IGF-1 o somatomedina C)
C) Tomografía computarizada de cerebro sin contraste
D) Radiografía de manos para evaluar espolones óseos
E) Prueba de estimulación con GHRH

PREGUNTA 84 1.04.1.015

**84.** **En un paciente con alta sospecha clínica de acromegalia y niveles séricos de IGF-1 elevados para su rango etario, ¿cuál es la prueba de confirmación diagnóstica estándar de oro que debe realizarse para demostrar la secreción autónoma de hormona de crecimiento?**

A) Test de tolerancia a la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa (PTGO) con medición seriada de GH
B) Test de hipoglicemia inducida por insulina
C) Medición seriada de prolactina cada 15 minutos
D) Test de supresión con dexametasona 8 mg
E) Biopsia estereotáxica transcraneal

PREGUNTA 85 1.03.1.014

**85.** **Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. El diagnóstico más probable es:**

A) Tiroiditis postparto
B) Panhipopituitarismo
C) Depresión postparto
D) Insuficiencia ovárica
E) Hipotiroidismo

PREGUNTA 86 1.04.1.016

**86.** **Una paciente de 35 años con antecedente de shock hipovolémico por hemorragia del alumbramiento hace 1 año presenta fracaso de lactancia, amenorrea persistente, astenia extrema e hipotensión. Se confirma panhipopituitarismo por Síndrome de Sheehan con T4 libre y cortisol plasmático severamente disminuidos. Respecto al inicio de su terapia de reemplazo hormonal, ¿cuál es la regla de seguridad cronológica obligatoria que debe respetarse?**

A) Iniciar levotiroxina a dosis plenas de inmediato y posponer los glucocorticoides hasta que la TSH se normalice
B) Iniciar tratamiento glucocorticoide con Hidrocortisona en primer lugar, y solo después de 24 a 48 horas comenzar la sustitución con Levotiroxina
C) Iniciar estrógenos orales antes que cualquier otra hormona para proteger la masa ósea
D) Administrar hormona de crecimiento humana recombinante en monoterapia
E) No iniciar medicamentos hormonales y derivar a fisioterapia

PREGUNTA 87 1.04.1.016

**87.** **Una mujer de 42 años diagnosticada de hipopituitarismo secundario a la resección de un macroadenoma selar se encuentra en tratamiento de reemplazo con levotiroxina 100 mcg/día e hidrocortisona 20 mg/día. Acude a su primer control ambulatorio. ¿Cuál es el examen de laboratorio adecuado que debe solicitarse para titular y ajustar la dosis de levotiroxina en esta paciente?**

A) TSH sérica ultrasensible exclusivamente
B) T4 libre plasmática
C) T3 reversa plasmática
D) Anticuerpos anti-TPO
E) Tiroglobulina sérica

PREGUNTA 88 1.03.1.015

**88.** **Niño operado de cirugía cerebral, luego presenta hipernatremia y poliuria. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)
B) Diabetes mellitus tipo 1
C) Hiperaldosteronismo secundario
D) Diabetes insípida central
E) Polidipsia psicogénica

PREGUNTA 89 1.04.1.017

**89.** **Un paciente de 25 años sometido a la extirpación quirúrgica de un craneofaringioma supraselar presenta en el postoperatorio inmediato una diuresis abrupta de 600 mL/hora durante 4 horas consecutivas. El laboratorio demuestra una densidad urinaria de 1.002, osmolaridad urinaria de 110 mOsm/kg y una natremia que asciende rápidamente a 152 mEq/L. Tras la administración de 2 mcg de Desmopresina (DDAVP) por vía subcutánea, la diuresis disminuye a 80 mL/hora y la osmolaridad urinaria se eleva a 520 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de pérdida cerebral de sal
B) Diabetes Insípida Central aguda postquirúrgica
C) Diabetes Insípida Nefrogénica
D) Diuresis osmótica por hiperglicemia
E) Síndrome de secreción inadecuada de ADH

PREGUNTA 90 1.04.1.017

**90.** **Una paciente de 32 años consulta para asesoramiento genético. Refiere que a su madre le diagnosticaron hiperparatiroidismo primario por adenomas en múltiples glándulas paratiroides y que a su hermano le extirparon un prolactinoma hipofisario y un tumor neuroendocrino pancreático productor de gastrina (gastrinoma). ¿Cuál de los siguientes genes es el responsable más probable de esta agregación familiar de neoplasias endocrinas múltiples?**

A) Protooncogén RET
B) Gen supresor de tumores MEN1 (Menina)
C) Gen supresor tumoral VHL
D) Gen NF1
E) Gen del receptor de TSH

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 PATOLOGÍA TIROIDEA FUNCIONAL: HIPOTIROIDISMO Y TIROIDITIS · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: D

1.03.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

El hipotiroidismo se caracteriza por la piel seca. El mixedema pretibial y exoftalmo son de la enfermedad de Basedow Graves, las melanoplaquias de la enfermedad de Addison y la acantosis nigricans, de la resistencia a la insulina.

### PREGUNTA 2 Respuesta: B

1.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, cuyo tratamiento son los AINEs. No se usan las drogas antitiroideas y no sirve el yodo radiactivo (de hecho, no capta). El betabloqueo sí se usa cuando hay síntomas de hiperT4, pero lo más importante son los AINEs.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A

1.03.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome climatérico" (1.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

1.03.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de secreción inapropiada de ADH" (1.03.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 5 Respuesta: C

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

El cuadro corresponde al Síndrome del Eutiroideo Enfermo (o síndrome de T3 baja), una alteración funcional fisiológica frecuente en pacientes críticos debida al bloqueo de la 5'-desyodasa tisular inducido por citoquinas inflamatorias y cortisol. La administración de levotiroxina o T3 no solo no ha demostrado beneficio en la sobrevida sino que puede incrementar el catabolismo y la mortalidad. La conducta estándar es mantener una actitud expectante y reevaluar las pruebas tiroideas una vez superada la patología crítica de base.

### PREGUNTA 6 Respuesta: B

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo**

La definición diagnóstica bioquímica de Hipotiroidismo Subclínico exige la concurrencia de una concentración plasmática de TSH por encima del límite superior normal (típicamente > 4.5 mIU/L, en este caso 7.4 mIU/L) con una concentración sérica de Tiroxina Libre (T4L) que se mantiene estrictamente dentro de los rangos de referencia normales (1.2 ng/dL).

**PREGUNTA 7** **Respuesta: D**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina**

En pacientes adultos mayores (> 60 años) o con antecedentes de cardiopatía coronaria (infarto agudo de miocardio previo), el inicio de la terapia sustitutiva con levotiroxina debe ser cauteloso ("start low, go slow"). Iniciar la dosis completa sustitutiva (1.6 mcg/kg/d) puede desencadenar un aumento brusco del consumo miocárdico de oxígeno, precipitando crisis de angina, infarto agudo o arritmias ventriculares graves. La conducta recomendada es iniciar con 25 a 50 mcg/día (o incluso 12.5-25 mcg en coronarios inestables) e incrementar progresivamente en 12.5-25 mcg cada 6 a 8 semanas según el nivel de TSH.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina**

La paciente presenta un hipotiroidismo subclínico (TSH entre 4.5 y 9.9 con T4L normal) con dos factores de indicación formal indiscutida para iniciar levotiroxina: 1) Deseo inminente de embarazo (donde la meta preconcepcional y del primer trimestre es TSH < 2.5 mIU/L para optimizar la fertilidad y prevenir pérdidas reproductivas y daño en el neurodesarrollo fetal); y 2) Presencia de anticuerpos Anti-TPO positivos a títulos altos, lo que confiere un alto riesgo de progresión rápida a falla clínica durante la gestación. La indicación es iniciar levotiroxina 25 a 50 mcg/día.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: C**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina**

La tiroxina (T4) tiene una vida media plasmática prolongada de aproximadamente 7 días. Por consiguiente, se requieren al menos 5 a 6 vidas medias (unas 4 a 6 semanas) para alcanzar un nuevo estado de equilibrio plasmático estacionario y un tiempo adicional para que el eje hipofisario reajuste plenamente la secreción de TSH. Las guías clínicas universales establecen que el control de TSH debe solicitarse a las 6 a 8 semanas tras el inicio o cambio de dosis de levotiroxina.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina**

La levotiroxina requiere un pH gástrico ácido y un medio libre de alimentos para su adecuada absorción en el intestino delgado. El consumo concomitante con alimentos, café con leche, suplementos de calcio y sales de hierro quelan el fármaco en el lumen intestinal y disminuyen su biodisponibilidad hasta en un 50–70%, provocando una aparente resistencia al tratamiento. La indicación correcta es instruir la ingesta de levotiroxina en ayuno estricto con agua pura al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno, y distanciar el calcio y el hierro por al menos 4 horas.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: D**

1.03.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas**

Tiene un coma mixedematoso, en contexto de una GroidiGs autoinmune (reforzada por el viVligo y la anemia perniciosa, que son autoinmunes). La primera medida es dar corticoides EV, seguidos de la levoGroxina EV. Si se da directamente la levoGroxina existe riesgo de producir una insuficiencia suprarrenal aguda.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas**

En el tratamiento del coma mixedematoso es una regla de seguridad biológica primordial administrar hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo seguido de 100 mg cada 8 horas) antes o junto con la administración de levotiroxina. La administración aislada de hormona tiroidea incrementa súbitamente el aclaramiento metabólico hepático del cortisol circulante, lo que en pacientes con reserva adrenal agotada desencadenará una crisis suprarrenal aguda fulminante con shock irreversible y muerte.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: C**

**Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En el coma mixedematoso el recalentamiento debe ser estrictamente pasivo mediante el uso de frazadas o mantas convencionales en una sala climatizada. El recalentamiento activo externo rápido (como baños calientes o mantas térmicas potentes) está formalmente contraindicado porque provoca una vasodilatación periférica brusca e incontrolable que secuestra el volumen sanguíneo en el lecho cutáneo, precipitando un colapso cardiovascular profundo, shock distributivo y muerte por isquemia coronaria.

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

**Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El hipotiroidismo severo reduce la tasa de filtración glomerular y la entrega de agua al túbulo distal, estimulando al mismo tiempo la secreción no osmótica de vasopresina (ADH). Esto conduce a una retención severa de agua libre que se traduce clínicamente en una hiponatremia dilucional significativa (frecuentemente < 125 mEq/L). Además, la menor gluconeogénesis y la probable coexistencia de insuficiencia adrenal condicionan una tendencia marcada a la hipoglicemia.

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

**Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas**

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Las hormonas tiroideas modulan directamente la expresión de las cadenas pesadas de miosina (alfa-MHC) y la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico por la bomba SERCA2a en los miocitos cardíacos. Su carencia crítica en el coma mixedematoso produce una severa disfunción inotrópica y cronotrópica negativa con bajo gasto cardíaco refractario al aporte de volumen, requiriendo el inicio de soporte inotrópico y vasopresor mientras la levotiroxina ejerce su efecto genómico.

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

**Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito**

1.05.1.005, 4.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Al confirmarse el embarazo, los requerimientos maternos de tiroxina aumentan precozmente entre un 20% y un 50% debido a la elevación de la TBG por hiperestrogenismo, la transferencia transplacentaria de T4 al feto y la degradación placentaria de hormonas tiroideas. Las guías internacionales y del MINSAL recomiendan enfáticamente instruir a las pacientes hipotiroideas a incrementar su dosis en dos comprimidos semanales (aumento del 25-30%) de manera inmediata al confirmar el embarazo, realizando un control de TSH cada 4 semanas para ajustar la dosis.

**PREGUNTA 17** **Respuesta: C**

**Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito**

1.05.1.005, 4.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Inmediatamente después del nacimiento se produce una elevación fisiológica súbita y marcada de TSH en el recién nacido ("pico neonatal de TSH") inducida por el enfriamiento térmico extrauterino, la cual desciende gradualmente en las primeras 24 a 36 horas. Para evitar una tasa inaceptable de falsos positivos, la norma técnica del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal de Chile (Garantía GES) establece que la muestra de sangre de talón debe recolectarse entre las 40 y 48 horas de vida (o idealmente entre el 2° y 3° día, antes del alta hospitalaria).

**PREGUNTA 18** **Respuesta: C**

**Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)**

1.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hipercalcemia sintomática/severa (Ca >12 mg/dL con síntomas): tratamiento de urgencia = hidratación EV agresiva con SF 0.9% (200-300 mL/h) para promover calciuria. Luego agregar bifosfonatos (zoledronato) o calcitonina. La cintigrafía es para planificación quirúrgica electiva, no urgente.

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A** Hipertiroidismo 1.03.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hipertiroidismo + exoftalmo (oftalmopatía de Graves) + bocio difuso en mujer joven = enfermedad de Graves-Basedow (autoinmune, anticuerpos anti-TSH-R). El exoftalmo es patognomónico.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.03.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bocio" (1.03.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.03.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del tiroides" (1.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 22**

**Respuesta: B**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.04.1.002 Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo GES

La presencia de fiebre y odinofagia en un paciente bajo tratamiento con tionamidas (tiamazol o propiltiouracilo) constituye una sospecha ineludible de agranulocitosis medicamentosa (neutrófilos absolutos < 500/uL), complicación inmunológica potencialmente letal. La regla diagnóstica y terapéutica estricta es suspender inmediatamente el fármaco antitiroideo, solicitar un hemograma de urgencia con recuento absoluto de neutrófilos e iniciar aislamiento protector y estudio infeccioso. Si se confirma neutropenia severa, se hospitaliza, se administran antibióticos endovenosos de amplio espectro y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Nunca debe sustituirse por PTU debido a reactividad cruzada de hasta un 50%.

---

**PREGUNTA 23**

**Respuesta: B**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.04.1.002 Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo GES

El tiamazol está formalmente contraindicado durante el primer trimestre de la gestación (semanas 1 a 12) debido a su potencial teratogénico, asociándose a la embriopatía por tiamazol (aplasia cutis congénita, atresia de coanas y atresia esofágica). Por esta razón, en toda mujer con hipertiroidismo por Graves que inicia un embarazo, el fármaco de elección obligatorio durante el primer trimestre es el Propiltiouracilo (PTU). Posteriormente, a partir de la semana 13-16 (segundo y tercer trimestre), suele rotarse nuevamente a tiamazol para minimizar el riesgo materno de hepatitis tóxica fulminante inducida por PTU.

---

## PREGUNTA 24

**Respuesta: C**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.04.1.002

Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo

GES

El cuadro clínico y cintigráfico es clásico de un Adenoma Tóxico Autónomo (enfermedad de Plummer unilocular). Se caracteriza por la presencia de un nódulo hipercaptante ('caliente') que produce hormonas tiroideas de manera autónoma e independiente de la regulación por TSH. La hiperproducción hormonal suprime la secreción hipofisaria de TSH, lo que conduce a la inactivación y abolición funcional de la captación en el resto de la glándula tiroidea normal. Es más prevalente en adultos mayores, no se acompaña de oftalmopatía ni mixedema, los TRAb son negativos y con frecuencia debuta con fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca descompensada.

---

## PREGUNTA 25

**Respuesta: B**

**Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos**

1.04.1.002

Dx: TSH suprimida (< 0.01 mIU/L), T4L/T3 elevadas, TRAb positivos (> 1.75 UI/L) y ecografía doppler con infierno tiroideo · Tx: Tiamazol 10-30 mg/día (o PTU en 1er trimestre), betabloqueo sintomático (propranolol/atenolol), radioyodo I-131 o tiroidectomía · Seg: Control T4L/T3 a las 4-6 semanas (la TSH puede permanecer suprimida meses). Monitoreo estricto de neutrófilos si fiebre o dolor faríngeo

GES

En pacientes con Enfermedad de Graves y orbitopatía distiroidea moderada a severa activa, el radioyodo I-131 como monoterapia está desaconsejado o formalmente contraindicado relativo, ya que la liberación masiva de antígenos tiroideos provocada por la radiación exacerba marcadamente la inflamación autoinmune retroocular y puede amenazar la visión. En este contexto, la cirugía ablativa (tiroidectomía total) realizada por un equipo experto tras alcanzar eutiroidismo con tionamidas y Lugol es la opción de elección. Si por algún motivo se optara por I-131, es imperativo asociar profilaxis sistémica con glucocorticoides orales (prednisona 0.4-0.5 mg/kg/día iniciada el mismo día del I-131 y mantenida durante 6 semanas con desescalamiento paulatino).

---

## PREGUNTA 26

**Respuesta: B**

**Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía**

1.04.1.002

Dx: Evaluación de etiología tiroidea, severidad clínica, comorbilidades cardiovasculares, deseo gestacional y orbitopatía activa · Tx: Tiamazol (1ra línea médica), Radioyodo I-131 (elección en recidivas/BMNT), Tiroidectomía total (bocios gigantes, compresión o sospecha CA) · Seg: Perfil tiroideo a las 4-6 semanas de inicio médico; seguimiento anual con TSH tras I-131 o cirugía por desarrollo inexorable de hipotiroidismo

GES

El radioyodo I-131 destruye el tejido tiroideo hiperfuncionante mediante radiación beta local. En el seguimiento a mediano y largo plazo, la gran mayoría de los pacientes tratados (> 80%) desarrollan hipotiroidismo definitivo, lo cual no se considera un fracaso del tratamiento sino la consecuencia biológica esperada del proceso ablativo curativo. Por esta razón, se les debe advertir formalmente que requerirán controles periódicos de TSH y suplementación diaria indefinida con levotiroxina oral. La lactancia es una contraindicación absoluta para el radioyodo.

---

## PREGUNTA 27

**Respuesta: A**

**Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía**

1.04.1.002

Dx: Evaluación de etiología tiroidea, severidad clínica, comorbilidades cardiovasculares, deseo gestacional y orbitopatía activa · Tx: Tiamazol (1ra línea médica), Radioyodo I-131 (elección en recidivas/BMNT), Tiroidectomía total (bocios gigantes, compresión o sospecha CA) · Seg: Perfil tiroideo a las 4-6 semanas de inicio médico; seguimiento anual con TSH tras I-131 o cirugía por desarrollo inexorable de hipotiroidismo

GES

La administración de solución de Lugol (o SSKI, solución saturada de yoduro de potasio) durante 7 a 10 días inmediatamente previos a la cirugía es la práctica estándar en la preparación preoperatoria de la tiroidectomía en pacientes con hipertiroidismo. Las altas concentraciones de yoduro inorgánico desencadenan el efecto Wolff-Chaikoff transitorio (inhibiendo la proteólisis del coloide y la liberación hormonal) y producen una marcada vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo glandular, lo que reduce ostensiblemente el tamaño de los vasos tiroideos, la fragilidad tisular y el riesgo de hemorragia intraoperatoria masiva.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

**Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas**

1.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Tormenta tiroidea" como urgencia clínica (1.03.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 29**

**Respuesta: B**

**Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas**

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

El tratamiento de la tormenta tiroidea debe ser multimodal e instaurado sin demora: 1) Betabloqueo enérgico (propranolol) para controlar la toxicidad adrenérgica; 2) Propiltiouracilo (PTU) para inhibir la síntesis hormonal folicular y bloquear la conversión periférica de T4 a T3; 3) Hidrocortisona endovenosa para compensar la insuficiencia suprarrenal relativa; y 4) Solución de Lugol o SSKI para bloquear la liberación de hormonas preformadas mediante el efecto Wolff-Chaikoff. Es una regla de seguridad estricta diferir el yoduro inorgánico al menos una hora después del PTU para evitar que la glándula lo utilice como sustrato para sintetizar más hormonas (efecto Jod-Basedow). Los salicilatos están contraindicados.

---

**PREGUNTA 30**

**Respuesta: C**

**Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas**

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

El ácido acetilsalicílico (aspirina) y otros salicilatos están absolutamente contraindicados en el contexto de tirotoxicosis y tormenta tiroidea. Los salicilatos compiten con gran afinidad por los sitios de unión de la globulina fijadora de tiroxina (TBG) y la transtiretina, desplazando a la tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) de su unión proteica y disparando de forma brusca las concentraciones séricas de T4 y T3 libres biológicamente activas. Esto intensifica la tormenta tiroidea y precipita colapso cardiovascular. El antipirético de elección es el Paracetamol junto a medios físicos.

---

**PREGUNTA 31**

**Respuesta: A**

**Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas**

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

En el estado de hipermetabolismo extremo que caracteriza a la tormenta tiroidea, la degradación y el clearance hepático de cortisol están fuertemente acelerados, superando la capacidad de reserva de la corteza suprarrenal para sintetizar glucocorticoides ('insuficiencia suprarrenal relativa'). La administración de hidrocortisona EV a dosis de estrés (100 mg cada 8 horas) es vital para prevenir el colapso hemodinámico letal secundario a hipocortisolismo, al mismo tiempo que ejerce un efecto sinérgico inhibitorio sobre la enzima 5'-desyodasa, bloqueando la conversión periférica de T4 a T3.

---

**PREGUNTA 32**

**Respuesta: B**

**Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas**

1.04.1.002 Dx: Clínico urgente mediante Escala de Burch-Wartofsky (≥ 45 puntos = Tormenta Tiroidea altamente probable) · Tx: Abordaje multimodal simultáneo: Bloqueo adrenérgico (Propranolol EV/oral) + PTU alta dosis + Yodo inorgánico (1 h post-PTU) + Hidrocortisona EV · Seg: Monitorización continua en UCI/UTI, hemodinamia invasiva, control electrolítico y detección de infecciones desencadenantes GES

La glándula tiroidea hiperactiva en una tormenta capta ávidamente cualquier molécula de yoduro presente en circulación. Si se administra yoduro inorgánico (solución de Lugol o SSKI) antes de haber bloqueado la peroxidasa tiroidea con una tionamida (propiltiouracilo), el exceso masivo de yodo sirve de sustrato directo para la organificación y síntesis de grandes cantidades adicionales de T4 y T3 (efecto Jod-Basedow), lo que agrava de forma letal la tirotoxicosis. Por ello, el PTU debe administrarse primero y esperar al menos una hora para que bloquee la maquinaria enzimática antes de ingresar el yodo que provocará el efecto Wolff-Chaikoff (inhibición de la liberación).

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: A**

**Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF**

1.03.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta difícil, ya que el manejo general del nódulo tiroideo es 1. solicitar TSH (y T4 libre), 2. solicitar ecografía tiroidea (puede ser simultáneamente con la TSH), 3. si tiene más de 10 mm, solicitar PAAF. Sin embargo, la excepción es cuando está hipertiroideo, en que se debe pedir una cintigrafía tiroidea: como en este caso que la TSH está baja y, por tanto, tiene un hipertiroidismo subclínico (con T4 normal). Si es un nódulo caliente (hipercaptante), se diagnostica el adenoma tóxico y se debe extirpar. Si es frío (capta igual o menos que el resto de la tiroides), se procede a la punción.

---

**PREGUNTA 34**

**Respuesta: B**

**Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF**

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

En un paciente eutiroideo con un nódulo tiroideo que presenta características ecográficas de alta sospecha de malignidad (ACR TI-RADS 5: sólido, hipoecogénico, márgenes irregulares y microcalcificaciones) y cuyo diámetro mayor supera el umbral estandarizado de 1.0 cm (mide 1.8 cm), la conducta mandataria e inmediata es la realización de una Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía para categorización citológica según el sistema Bethesda. El cintigrama solo se solicita si la TSH estuviera suprimida, la terapia supresiva con levotiroxina está formalmente en desuso por ineficaz y riesgosa, y la observación diferiría el diagnóstico oncológico.

---

**PREGUNTA 35**

**Respuesta: C**

**Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF**

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

En el algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo, si la TSH se encuentra suprimida (< 0.4 mIU/L), el siguiente examen mandatorio es el Cintigrama Tiroideo (gammagrafía). Su objetivo es demostrar si el nódulo es hipercaptante ('caliente') o no captante ('frío'). Los nódulos calientes corresponden a adenomas tóxicos o nódulos autónomos, los cuales poseen un riesgo de malignidad prácticamente nulo (< 1%) y por norma internacional NO deben ser sometidos a PAAF, pasando directamente a tratamiento del hipertiroidismo.

---

**PREGUNTA 36**

**Respuesta: B**

**Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF**

1.04.1.003 Dx: TSH sérica + Ecografía tiroidea de alta resolución estandarizada con sistema ACR TI-RADS o ATA · Tx: Según resultado citológico Bethesda: Bethesda II (seguimiento ecográfico), Bethesda V/VI (cirugía oncológica), nódulos calientes (I-131/Cx) · Seg: Control ecográfico a los 6-12 meses según categoría de riesgo ecográfico y estabilidad dimensional GES

La categoría Bethesda IV (neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular) confiere un riesgo de malignidad intrínseco del 25 al 40%. La citología obtenida por PAAF solo permite visualizar la morfología celular folicular, pero es completamente incapaz de distinguir entre un Adenoma Folicular (benigno) y un Carcinoma Folicular (maligno), distinción que depende exclusivamente de demostrar invasión transcapsular o angioinvasión vascular en cortes histológicos de la pieza resecada en su totalidad. Por consiguiente, la conducta quirúrgica estándar es la Hemitiroidectomía (lobectomía tiroidea con istmectomía) para examen diferido. Solo si la biopsia definitiva confirma carcinoma invasor se programa la tiroidectomía total complementaria.

---

## BLOQUE 3 · BLOQUE 3 · CORTEZA Y MÉDULA SUPRARRENAL: CUSHING, ADDISON, CONN Y FEOCROMOCITOMA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: E** **Hirsutismo**

1.03.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

[Pregunta disputada] No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: D**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.03.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.03.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Incidentaloma suprarrenal" (1.03.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 40**

**Respuesta: B**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

En el algoritmo diagnóstico del Síndrome de Cushing, una vez confirmado el hipercortisolismo bioquímico mediante dos pruebas de primera línea positivas concordantes (en este caso Nugent y CLU de 24 horas), el paso siguiente e inexcusable consiste en determinar si el cuadro es ACTH-dependiente o ACTH-independiente mediante la medición de ACTH plasmática en sangre. Si la ACTH resulta suprimida (< 5-10 pg/mL), el estudio de imágenes se dirigirá a las glándulas suprarrenales (TC abdominal); si resulta normal-alta o francamente elevada (> 15-20 pg/mL), el estudio se dirigirá a la hipófisis (RM de silla turca) o a la búsqueda de foco ectópico.

---

**PREGUNTA 41**

**Respuesta: C**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

El cuadro clínico corresponde al Síndrome de Cushing Ectópico, clásicamente asociado a Carcinoma Pulmonar Microcítico o tumores neuroendocrinos/carcinoides. A diferencia de la Enfermedad de Cushing hipofisaria habitual, los tumores neuroendocrinos malignos producen concentraciones masivas de ACTH y precursores (POMC) de instauración rápida, lo que impide el desarrollo del fenotipo cushingoide típico (obesidad centrípeta) pero desencadena una severa hipokalemia con alcalosis metabólica (por activación cruzada masiva del receptor mineralocorticoide por el cortisol libre) e hiperpigmentación cutánea (por estimulación de receptores de melanocortina 1). La ausencia de supresión con 8 mg de dexametasona confirma la completa autonomía de la producción tumoral ectópica.

---

**PREGUNTA 42**

**Respuesta: B**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.04.1.005 Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje GES

En el Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal unilateral autónomo, los niveles suprafisiológicos crónicos de cortisol suprimen de forma prolongada la síntesis y secreción de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria, lo que induce una atrofia estructural y funcional severa de la corteza suprarrenal contralateral. Al extirpar quirúrgicamente el adenoma hipersecretor, el paciente pasa bruscamente de un estado de hipercortisolismo a una insuficiencia suprarrenal secundaria aguda potencialmente mortal (colapso circulatorio hemodinámico). Por ello, es mandatorio iniciar terapia sustitutiva con Hidrocortisona inmediatamente en el postoperatorio y mantenerla durante varios meses (generalmente 6 a 12 meses) hasta que el eje recupere su reactividad normal.

---

**PREGUNTA 43**

**Respuesta: B**

**Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico**

1.04.1.005

Dx: Demostrar hipercortisolismo con 2 pruebas de 1ra línea alteradas (CLU 24h, Nugent 1 mg, Cortisol salival nocturno) + ACTH plasmática · Tx: Según etiología: Resección transesfenoidal (Enfermedad de Cushing), Suprarrenalectomía laparoscópica (Adenoma), ketoconazol/metirapona · Seg: Monitoreo de cortisol post-quirúrgico y reemplazo temporal con hidrocortisona por insuficiencia suprarrenal secundaria a atrofia del eje

GES

Las tres pruebas de primera línea validadas internacionalmente y con mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica para demostrar hipercortisolismo patológico son: 1) Test de supresión con dexametasona 1 mg a las 23 h (Test de Nugent), considerando normal un cortisol plasmático < 1.8 mcg/dL a las 08 h; 2) Cortisol Libre Urinario (CLU) en orina de 24 horas; y 3) Cortisol salival nocturno (a las 23:00 h). El cortisol plasmático matinal aislado de las 08:00 h no tiene utilidad diagnóstica alguna debido a que se encuentra dentro del rango normal en la mayoría de los pacientes con Cushing, fallando en evaluar la pérdida del ritmo circadiano y la falta de autorregulación.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

**Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria**

1.03.1.007

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es una insuficiencia suprarrenal por TBC. Es la segunda causa de Addison, después de la causa autoinmune. En FB alguien puso K: 2,9 y en ese caso sería un síndrome de secreción ectópica de ACTH, que tiene una clínica totalmente distinta y que es un síndrome paraneoplásico.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria**

1.03.1.019

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Osteoporosis secundaria" (1.03.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: D**

**Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria**

1.03.2.003

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

GES

Tiene una crisis suprarrenal clásica: shock refractario, hiponatremia, hipoglicemia e hiperkalemia (el K+ está normal en este caso, pero en el límite alto). Sin embargo, también tiene una insuficiencia renal aguda (creatinina elevada), pero el diagnóstico más importante es la insuficiencia suprarrenal.

---

**PREGUNTA 47**

**Respuesta: C**

**Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria**

1.04.1.006

Dx: Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria · Tx: Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés · Seg: Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático

GES

El paciente presenta una Insuficiencia Suprarrenal Primaria (Enfermedad de Addison), confirmada por el cortisol < 3 mcg/dL, ACTH marcadamente elevada, hiperpigmentación cutáneo-mucosa y el trastorno hidroelectrolítico con hiponatremia e hiperkalemia severa secundario a déficit concomitante de mineralocorticoides. Al estar destruida la totalidad de la corteza suprarrenal, el paciente carece tanto de cortisol como de aldosterona. Por lo tanto, el esquema terapéutico sustitutivo crónico indispensable de por vida exige la combinación de un glucocorticoide (Hidrocortisona 15-25 mg/día repartidos) y un mineralocorticoide (Fludrocortisona 0.05-0.1 mg/día en toma matinal única).

---

## PREGUNTA 48

**Respuesta: B**

**Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria**

1.04.1.006

Dx: Cortisol plasmático matinal (< 3 mcg/dL confirma; 3-15 requiere test de ACTH/Synacthen). ACTH elevada confirma primaria (Addison); ACTH baja orienta a secundaria · Tx: Reemplazo con Hidrocortisona (15-25 mg/día en 2-3 tomas) + Fludrocortisona (0.05-0.1 mg/día SOLO en primaria/Addison). Educar ajuste por estrés · Seg: Monitoreo clínico (peso, PA de pie/sentado, energía), electrolitos plasmáticos y renina plasmática. NUNCA guiar dosis con cortisol plasmático

GES

La suspensión brusca de una corticoterapia sistémica administrada a dosis suprafisiológicas por más de 3 a 4 semanas es la causa más común de Insuficiencia Suprarrenal Secundaria/Terciaria. El glucocorticoide exógeno inhibe de forma persistente la síntesis de CRH hipotalámica y ACTH hipofisaria (demostrada por la ACTH suprimida de 4 pg/mL), conduciendo a la atrofia por desuso de la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal. Dado que la zona glomerulosa productora de aldosterona no depende de ACTH sino del sistema renina-angiotensina, la aldosterona se encuentra conservada, razón por la cual los niveles de potasio son rigurosamente normales (K+ 4.2 mEq/L) y no se produce hiperpigmentación.

---

## PREGUNTA 49

**Respuesta: C**

**Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario**

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

El paciente presenta una Crisis Suprarrenal Aguda con shock refractario a volumen desencadenado por una sepsis de foco respiratorio. En ausencia de concentraciones adecuadas de cortisol, las arteriolas pierden la reactividad normal a las catecolaminas endógenas y exógenas debido al downregulation funcional de los receptores adrenérgicos vasculares, lo que perpetúa la vasodilatación sistémica letal. La administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg en bolo endovenoso restaura el tono vascular, restablece la permeabilidad capilar y permite recuperar la presión arterial. Administrar noradrenalina sin corticoides en este contexto es completamente ineficaz.

---

## PREGUNTA 50

**Respuesta: B**

**Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario**

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

El cuadro clínico de colapso hemodinámico a las 2 semanas de vida con crisis de pérdida salina severa (hiponatremia extrema Na+ 118 y severa hiperkalemia K+ 7.8) e hiperpigmentación genital es la presentación clásica y potencialmente fatal de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita en su forma clásica perdedora de sal por déficit de la enzima 21-hidroxilasa. La incapacidad para sintetizar cortisol y aldosterona genera una crisis suprarrenal neonatal aguda. El tratamiento urgente e inaplazable consiste en reanimación con suero fisiológico isotónico para expandir la volemia y administración precoz de Hidrocortisona endovenosa.

---

## PREGUNTA 51

**Respuesta: B**

**Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario**

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

Una de las reglas de oro de mayor relevancia y evaluación en el examen EUNACOM ante la sospecha fundada de Crisis Suprarrenal Aguda es que el tratamiento de rescate es una URGENCIA VITAL INAPLAZABLE. Bajo ninguna circunstancia se debe retrasar o posponer la administración de la Hidrocortisona endovenosa a la espera de los resultados de laboratorio o pruebas diagnósticas complementarias. La mortalidad de esta condición en ausencia de tratamiento glucocorticoide inmediato es altísima debido a la falla circulatoria refractaria. La conducta estándar es extraer la muestra sanguínea y administrar de inmediato el fármaco.

---

**PREGUNTA 52**

**Respuesta: B**

1.04.1.006

Dx: Sospecha clínica inmediata ante shock hipotensivo refractario a fluidos y aminas vasoactivas en paciente con antecedente adrenal o corticoterapia previa · Tx: Hidrocortisona 100 mg bolo EV inmediato + Reposición agresiva con Suero Fisiológico al 0.9% y Suero Glucosado al 5-10% EV. NUNCA diferir por exámenes · Seg: Hospitalización en UCI/UTI, monitoreo hemodinámico continuo invasivo, corrección de hipoglicemia e hiperkalemia, y búsqueda de foco séptico desencadenante

GES

**Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario**

La molécula de hidrocortisona posee afinidad intrínseca equivalente tanto por el receptor glucocorticoide como por el receptor mineralocorticoide. A dosis de sustitución fisiológica crónica (20 mg/día), la enzima 11beta-HSD2 inactiva el cortisol a cortisona en el riñón, requiriendo el aporte adicional de fludrocortisona en pacientes con Addison. Sin embargo, a dosis de estrés suprafisiológicas utilizadas en la crisis aguda (≥ 100 a 200 mg/día de hidrocortisona), la capacidad enzimática de la 11beta-HSD2 se satura masivamente por completo, permitiendo que el exceso de cortisol active con máxima potencia los receptores mineralocorticoides de los túbulos renales, ejerciendo una acción retenedora de sal y excretora de potasio idéntica a la aldosterona.

---

**PREGUNTA 53**

**Respuesta: B**

1.04.1.007

Dx: Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal · Tx: Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona) · Seg: Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)

GES

**Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria**

El examen de tamizaje de primera línea universalmente recomendado para evaluar la sospecha de Hiperaldosteronismo Primario es la Relación entre la concentración de Aldosterona Plasmática y la Actividad de Renina Plasmática (RAR). En condiciones normales, el eje renina-angiotensina regula a la aldosterona; en el hiperaldosteronismo primario la secreción autónoma de aldosterona expande el volumen extracelular y suprime potentemente la renina, generando una RAR marcadamente elevada (> 20 a 30 con aldosterona > 15 ng/dL). El estudio de imágenes (TC adrenal) solo se solicita tras la confirmación bioquímica de la prueba de tamizaje.

---

**PREGUNTA 54**

**Respuesta: B**

1.04.1.007

Dx: Relación Aldosterona / Renina Plasmática (RAR > 20-30 con Aldosterona > 15 ng/dL) + Test confirmatorio (sobrecarga salina) + TC Suprarrenal · Tx: Adenoma unilateral (Conn): Suprarrenalectomía laparoscópica unilateral curativa. Hiperplasia bilateral: Antagonistas del receptor mineralocorticoide (Espironolactona) · Seg: Monitorización de presión arterial, kalemia y función renal. Monitoreo de ginecomastia con espironolactona (rotar a Eplerenona si efectos adversos)

GES

**Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria**

En pacientes con Hiperaldosteronismo Primario debido a Hiperplasia Suprarrenal Bilateral (la causa más frecuente de HAP, representando el 60-65% de los casos), la cirugía resectiva no está indicada debido a que requeriría suprarrenalectomía bilateral con consecuente insuficiencia suprarrenal primaria permanente de por vida. El tratamiento estándar de elección indiscutido es el manejo médico con un antagonista competitivo del receptor mineralocorticoide, siendo la Espironolactona el fármaco de primera línea (a dosis de 25 a 100 mg/día). Este fármaco bloquea la acción de la aldosterona a nivel del túbulo colector, normalizando la presión arterial y reteniendo potasio para revertir la hipokalemia.

---

## BLOQUE 4 · METABOLISMO MINERAL, CALCIO, PARATIROIDES Y HUESO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene hipercalcemia, con elevación de la PTH, así que se confirma el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene la calcemia baja o normal y suele ser por IRC. El terciario es igual al primario, pero en un paciente con IRC, que tenía uno secundario y luego empezó a tener hipercalcemia, en lugar de la hipocalcemia del secundario. La hipercalcemia maligna tiene PTH baja. La hipercalciuria primaria sí tiene litiasis, pero la PTH y la calcemia son normales. El hiperparatiroidismo primario tiene hipercalciuria secundaria y, por ello, se produce la litiasis también.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Calcio alto y PTH alta son característicos del HPP.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

PTH es el primer examen a solicitar en hipercalcemia: PTH elevada = hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en ambulatorio). PTH suprimida = hipercalcemia de malignidad, intoxicación vitamina D u otras causas. Orienta todo el estudio.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Hipercalcemia + hipofosforemia + PTH inapropiadamente elevada en paciente asintomático = hiperparatiroidismo primario. Es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. PTH suprimida en malignidad.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hipercalcemia, con la posibilidad de ser secundaria al cáncer. Igualmente se estudia con PTH, ya que si está elevada es un hiperparatiroidismo primario y si está baja, es probablemente un cáncer.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: C** **Hipercalcemias e hipocalcemias** 1.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Aunque tenga imágenes de metástasis, también pueden ser causadas por un hiperparatiroidismo primario (HPP). Por eso es que la hipercalcemia se estudia siempre con PTH: si está elevada es un HPP y si está baja es cáncer. La cintigrafía ósea es una forma de buscar metástasis que no se han visto (en este caso ya las vio la radiografía) y se pide, por ejemplo, en la etapificación del cáncer de próstata con APE mayor a 20; sin embargo, es inespecífica, porque también se altera con otros procesos de hiperactividad ósea (osteoclástica), como el HPP.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: B** **Tetania** 1.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Gluconato de calcio endovenoso

---

**PREGUNTA 62**

**Respuesta: B**

**Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico**

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

El paciente se encuentra cursando una Crisis Hipercalcémica Severa (calcio corregido ≥ 14 mg/dL) de origen neoplásico (PTH suprimida, secundario a secreción tumoral de PTHrP). Los pacientes con hipercalcemia severa presentan invariablemente una depleción masiva de volumen intravascular (déficit de 3 a 5 litros de agua y electrolitos) debido a la diuresis osmótica nefrogénica inducida por calcio y los vómitos. La medida inicial de máxima prioridad e indiscutible antes de cualquier otra intervención es la restitución enérgica de volumen con Suero Fisiológico al 0.9% (2 a 4 litros en las primeras 24 horas). Esto restaura la perfusión renal e induce calciuresis salina. La furosemida está contraindicada en deshidratación, y el zoledronato requiere expansión de volumen previa.

---

**PREGUNTA 63**

**Respuesta: A**

**Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico**

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

Ante el hallazgo confirmado de hipercalcemia, la prueba diagnóstica cardinal para categorizar el mecanismo fisiopatológico es la medición de Hormona Paratiroidea Intacta (PTHi). En condiciones fisiológicas normales, una concentración sérica elevada de calcio suprime por completo la liberación de PTH por las glándulas paratiroides mediante la estimulación del receptor sensor de calcio (CaSR). Si la PTH intacta se encuentra elevada o 'inapropiadamente normal' (no suprimida) en coexistencia con hipercalcemia, se establece formalmente el diagnóstico de Hiperparatiroidismo Primario (o raramente hipercalcemia hipocalciúrica familiar).

---

**PREGUNTA 64**

**Respuesta: B**

**Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico**

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

De acuerdo con el consenso de las Guías Internacionales sobre el Manejo del Hiperparatiroidismo Primario Asintomático, la paciente cumple múltiples criterios formales de indicación quirúrgica de Paratiroidectomía: 1) Edad menor de 50 años (tiene 44 años); 2) Calcio sérico > 1.0 mg/dL por encima del límite superior normal (11.8 mg/dL vs límite 10.5); 3) Osteoporosis demostrada por densitometría ósea con T-score < -2.5 (presenta -2.7 en columna lumbar); y 4) Presencia de nefrolitiasis asintomática demostrada por imagen. La paratiroidectomía es el único tratamiento curativo definitivo, el cual normaliza la calcemia y revierte la pérdida de masa ósea.

---

**PREGUNTA 65**

**Respuesta: A**

**Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico**

1.04.1.009

Dx: Calcio total corregido por albúmina o Calcio Iónico + PTH intacta (PTHi). PTH elevada/inapropiada = HPT 1°; PTH suprimida = Neoplasia / Vit D · Tx: Crisis aguda: Suero fisiológico 0.9% enérgico + Ácido Zoledrónico EV +/- Calcitonina. HPT 1°: Paratiroidectomía si cumple criterios · Seg: Calcio sérico, fósforo y función renal post-resección. Monitoreo de hipocalcemia severa por 'Síndrome del Hueso Hambriento'

GES

El cuadro corresponde al Síndrome del Hueso Hambriento (Hungry Bone Syndrome), una complicación postoperatoria típica tras la paratiroidectomía en pacientes que presentaban hiperparatiroidismo primario de larga data o con compromiso óseo severo previo. Al extirpar bruscamente el adenoma hipersecretor de PTH, cesa de forma súbita la resorción osteoclástica masiva inducida por la PTH, mientras que los osteoblastos previamente estimulados captan con extrema avidez cantidades masivas de calcio y fósforo desde la sangre para remineralizar la matriz ósea desmineralizada. Esto provoca una caída abrupta y profunda tanto del calcio sérico (hipocalcemia sintomática severa) como del fósforo (hipofosfatemia concomitante). Requiere aporte masivo de calcio endovenoso y calcitriol oral a dosis altas.

---

**PREGUNTA 66**

**Respuesta: B**

**Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia**

1.04.1.010

Dx: Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek) · Tx: Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia · Seg: Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico

GES

La paciente presenta una hipocalcemia aguda sintomática severa con signos de tetania e inicio de laringoespasmo (estridor inspiratorio) secundario a hipoparatiroidismo post-tiroidectomía. Esta situación constituye una emergencia médica con riesgo inminente de asfixia por laringoespasmo o arritmias ventriculares letales por QT largo. El tratamiento de rescate inmediato de elección es la administración endovenosa lenta de Gluconato de Calcio al 10% (1 a 2 ampollas diluidas administradas en 10 a 20 minutos bajo monitor continuo de ECG). El calcio oral y la vitamina D son insuficientes y demasiado lentos para controlar una emergencia aguda de estas características.

---

**PREGUNTA 67**

**Respuesta: A**

**Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia**

1.04.1.010

Dx: Calcio total corregido por albúmina < 8.5 mg/dL o Calcio Iónico < 4.0 mg/dL (1.0 mmol/L) + Signos de irritabilidad neuromuscular (Trousseau / Chvostek) · Tx: Aguda sintomática: Gluconato de Calcio al 10% 1-2 ampollas EV en 10-20 min + infusión continua. Corregir magnesio si hipomagnesemia · Seg: Monitoreo cardíaco continuo (riesgo QT largo y arritmias). Monitoreo de calcemia, magnesemia y producto calcio-fósforo en tratamiento crónico

GES

La hipomagnesemia severa (< 1.0 mg/dL) es una causa clásica de hipocalcemia clínicamente indistinguible de la tetania por hipoparatiroidismo y profundamente refractaria a la administración aislada de calcio endovenoso. El magnesio es un cofactor indispensable tanto para la secreción fisiológica de PTH por las paratiroides como para la respuesta de los órganos diana (hueso y riñón) a la propia PTH. En pacientes con pérdidas gastrointestinales, uso crónico de diuréticos o alcoholismo desnutrido, la coexistencia de hipomagnesemia bloquea el eje del calcio. La administración de Sulfato de Magnesio EV es obligatoria para poder corregir la calcemia.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento**

1.03.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene osteoporosis (T score menor o igual a -2,5). Se deben iniciar los bifosfonatos. Se mantiene el calcio y la vit D

**PREGUNTA 69**

**Respuesta: B**

**Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento**

1.04.1.011 Dx: Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad · Tx: 1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d) · Seg: DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular GES

Una de las reglas cardinales más evaluadas en EUNACOM establece que la presencia de una Fractura por Fragilidad en un adulto mayor ante un traumatismo de bajo impacto (caída de su propia altura) en sitios típicos como cadera o vértebras establece el diagnóstico clínico inequívoco de OSTEOPOROSIS SEVERA / ESTABLECIDA, independientemente de que el valor densitométrico del T-score se encuentre en rango de osteopenia (-1.0 a -2.5). Por consiguiente, la paciente tiene indicación perentoria de iniciar tratamiento farmacológico antiosteoporótico activo de primera línea (bifosfonatos orales o zoledronato endovenoso) junto a calcio y vitamina D para reducir el elevado riesgo de una segunda fractura.

**PREGUNTA 70**

**Respuesta: B**

**Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento**

1.04.1.011 Dx: Densitometría ósea DEXA: T-score ≤ -2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera total, O presencia de fractura por fragilidad · Tx: 1ra Línea: Alendronato 70 mg/semana VO (o Ácido Zoledrónico 5 mg/año EV) + Calcio (1000-1200 mg/d) + Vitamina D3 (800-2000 UI/d) · Seg: DEXA de control cada 1-2 años. Evaluar 'vacaciones terapéuticas' con bifosfonatos a los 3-5 años por riesgo de fractura atípica de fémur y osteonecrosis mandibular GES

Los bifosfonatos orales (alendronato, risedronato) poseen una biodisponibilidad gastrointestinal extremadamente baja (< 1%) y son sumamente irritantes para el epitelio del esófago si permanecen en contacto prolongado con la mucosa. Para asegurar su absorción y prevenir la esofagitis ulcerativa por decúbito, se instruye a la paciente a: 1) Tomarlo en ayunas con un vaso completo (200 mL) de agua de la llave pura (los alimentos, lácteos, jugos y el calcio quelan el bifosfonato e impiden su absorción); 2) No consumir alimentos ni otros fármacos en los siguientes 30 a 60 minutos; y 3) Permanecer erguida (de pie o sentada) sin acostarse durante al menos 30 a 60 minutos.

**PREGUNTA 71**

**Respuesta: B**

**Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo**

1.04.1.012 Dx: 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima · Tx: Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día · Seg: Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia GES

El marcador biológico específico, validado internacionalmente y con mayor precisión diagnóstica para cuantificar los depósitos corporales de vitamina D y diagnosticar tanto su deficiencia como su insuficiencia es la 25-Hidroxivitamina D sérica [25(OH)D o calcidiol]. Posee una vida media plasmática de 2 a 3 semanas y refleja de manera fiel la síntesis cutánea solar y la ingesta dietética. La medición de 1,25-dihidroxivitamina D (calcitriol) es un error conceptual frecuente en la práctica y en el examen EUNACOM, dado que en estados tempranos de deficiencia la PTH se eleva estimulando la 1-alfa-hidroxilasa renal, manteniendo niveles normales o paradójicamente elevados de calcitriol.

**PREGUNTA 72**

**Respuesta: A**

**Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo**

1.04.1.012

Dx: 25-hidroxivitamina D sérica [25(OH)D]: < 20 ng/mL = Deficiencia; 20-29 ng/mL = Insuficiencia; ≥ 30 ng/mL = Suficiencia óptima · Tx: Deficiencia (< 20 ng/mL): Colecalciferol (D3) 50.000 UI semanal por 8 semanas (o 6.000 UI/día), seguido de mantención 1.000-2.000 UI/día · Seg: Control de 25(OH)D sérica a los 3-4 meses de iniciada la carga de reposición. Monitoreo de calcemia y fosfemia

GES

En pacientes con deficiencia severa de vitamina D (< 20 ng/mL y especialmente < 10 ng/mL) con osteomalacia clínica y bioquímica documentada, el esquema terapéutico estándar de reposición rápida recomendado por las guías endocrinológicas consiste en dosis altas de choque de Colecalciferol (vitamina D3) a razón de 50.000 UI vía oral una vez a la semana durante 8 semanas (o 6.000 UI diarias por 8 semanas). Este esquema repleta los depósitos tisulares saturando los receptores diana, y debe acompañarse obligatoriamente de 1.000 a 1.200 mg/día de calcio elemental. Los fármacos antirresortivos (como bifosfonatos) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS en presencia de osteomalacia activa no corregida porque empeoran la desmineralización ósea.

## BLOQUE 5 · BLOQUE 5 · HIPÓFISIS, HIPOTÁLAMO, NEUROENDOCRINOLOGÍA Y MEN · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: D** **Amenorrea**

1.03.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo- hipo es hipo-hipo).

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B** **Hipogonadismo masculino**

1.03.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es un hipogonadismo clínico (disminuición del vello corporal, astenia y disfunción sexual: impotencia y disminución del deseo sexual), que se estudia con gonadotropinas (LH) y hormonas sexuales (testosterona en el hombre).

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A** **Ginecomastia**

1.03.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ginecomastia bilateral en adolescente Tanner 3 sin medicamentos ni masa firme = ginecomastia puberal fisiológica. Ocurre en 50-70% de los púberes. Regresa espontáneamente en 1-2 años.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: D**

**Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria**

1.03.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es un hiperaldosteronismo clásico. La hipertensión renovascular también puede presentar hipokalemia (porque produce un hiperaldosteronismo secundario, por activación de eje renina – angiotensina – aldosterona), pero el resto de la clínica calza mejor con hiperaldosteronismo primario (mucha debilidad, calambres y cefalea). En cambio, la HTA RV tiene soplo abdominal y algo de elevación de la creatininemia.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: D**

**Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria**

1.03.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La acromegalia se estudia primero con somatomedina 1 o IGF1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

**PREGUNTA 78**

**Respuesta: B**

**Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria**

1.04.1.013

Dx: RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios · Tx: Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente · Seg: RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico

GES

En presencia de un Macroadenoma Hipofisario no funcionante (o clínicamente silente) que genera compromiso estructural de la vía visual evidenciado por hemianopsia bitemporal y compresión quiasmática evidente en la RM, la indicación de tratamiento de elección indiscutida es la Cirugía de Resección por vía Transesfenoidal (endoscópica o microquirúrgica). El objetivo primordial de la intervención es la descompresión mecánica urgente del quiasma óptico para permitir la recuperación funcional de los axones visuales y prevenir la atrofia óptica irreversible. Los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina son ineficaces para reducir significativamente los adenomas no prolactinomas.

---

**PREGUNTA 79**

**Respuesta: B**

**Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria**

1.04.1.013

Dx: RM de Silla Turca con gadolinio + Campo visual computarizado + Evaluación hormonal completa de todos los ejes hipofisarios · Tx: Compresión quiasmática o tumores no funcionantes grandes: Cirugía transesfenoidal. Apoplejía: Hidrocortisona EV inmediata +/- descompresión urgente · Seg: RM de control anual, campimetría periódica y seguimiento hormonal para pesquisar hipopituitarismo diferido postquirúrgico

GES

El paciente se encuentra cursando una Apoplejía Hipofisaria aguda hemorrágica con compresión de estructuras quiasmáticas y del seno cavernoso derecho (parálisis del III par). En esta catástrofe neuroendocrina, la necrosis hemorrágica masiva destruye bruscamente el tejido hipofisario remanente, provocando un hipopituitarismo agudo fulminante con colapso de la secreción de ACTH. La consiguiente crisis suprarrenal aguda secundaria es la causa primordial de mortalidad perioperatoria rápida por shock circulatorio refractario (como refleja su hipotensión PA 85/50). Por lo tanto, la medida inicial más urgente y prioritaria antes del traslado a pabellón neuroquirúrgico descompresivo es la administración inmediata de Hidrocortisona 100 mg EV en bolo directo.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: B**

**Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica**

1.03.1.016

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Tiene una hiperprolactinemia. No tiene la amenorrea clásica, porque usa anticonceptivos.

---

**PREGUNTA 81**

**Respuesta: B**

**Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica**

1.04.1.014

Dx: Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico · Tx: 1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia · Seg: Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas

GES

El tratamiento de primera línea de elección para los prolactinomas (tanto microadenomas como macroadenomas) es la terapia médica con agonistas dopaminérgicos, siendo la Cabergolina el fármaco de elección indiscutido debido a su alta eficacia, dosificación semanal cómoda y excelente perfil de tolerancia. La cabergolina normaliza los niveles de prolactina en más del 85% de las pacientes, induce una reducción volumétrica tumoral significativa y restaura los ciclos ovulatorios y la fertilidad normal en pocas semanas. La cirugía transesfenoidal queda relegada a casos excepcionales con resistencia demostrada o intolerancia grave a los agonistas.

---

**PREGUNTA 82**

**Respuesta: B**

**Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica**

1.04.1.014

Dx: Prolactina sérica basal > 25 ng/mL (en ayuno, sin estrés, reposo 30 min). > 100 ng/mL = Prolactinoma altamente probable; > 200 ng/mL = casi patognomónico · Tx: 1ra Línea ABSOLUTA: Agonistas Dopaminérgicos (Cabergolina 0.5 mg 1-2 veces/semana VO). Cirugía transesfenoidal solo si resistencia/intolerancia · Seg: Prolactina sérica a los 3 meses y RM de silla turca de control al año para evaluar reducción tumoral. Monitoreo de ecocardiograma si dosis altas

GES

La risperidona es un antipsicótico atípico que posee una potentísima actividad antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 a nivel del sistema nervioso central y periférico. Al bloquear los receptores D2 en los lactotropos de la adenohipófisis, interrumpe el tono inhibitorio tónico fisiológico que ejerce la dopamina sobre la secreción de prolactina, provocando una hiperprolactinemia farmacológica (habitualmente con niveles entre 30 y 100 ng/mL) que se manifiesta por galactorrea, oligomenorrea o amenorrea e hipoestrogenismo. Es una causa sumamente prevalente en la práctica que no requiere imágenes selares si el cuadro coincide con la introducción o aumento del fármaco.

---

**PREGUNTA 83**

**Respuesta: B**

**Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo**

1.04.1.015

Dx: Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L) · Tx: 1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido) · Seg: Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma

GES

El examen de tamizaje inicial de primera elección con mayor sensibilidad diagnóstica para la pesquisa de Acromegalia es la determinación sérica del Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1 (IGF-1 o Somatomedina C). A diferencia de la GH, cuyos niveles plasmáticos son pulsátiles y oscilan ampliamente a lo largo del día con picos aleatorios de estrés, la IGF-1 tiene una vida media prolongada y concentraciones estables en sangre que reflejan fielmente la actividad integrada de la GH durante las semanas previas. La medición de una GH basal matinal aislada es un error técnico grave y no se utiliza para tamizaje.

---

**PREGUNTA 84**

**Respuesta: A**

**Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo**

1.04.1.015

Dx: Tamizaje: IGF-1 sérica elevada para edad y sexo. Confirmación: Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO 75g con GH que no suprime a < 1.0 o 0.4 mcg/L) · Tx: 1ra Línea: Cirugía de Resección Transesfenoidal del adenoma somatotropo. Terapia médica coadyuvante: Análogos de Somatostatina (Octreótido/Lanreótido) · Seg: Monitoreo anual con IGF-1 y GH post-PTGO. Colonoscopía periódica (riesgo elevado de pólipos premalignos y cáncer colorrectal) y ecocardiograma

GES

La prueba diagnóstica estándar de oro confirmatoria de la Acromegalia es el Test de Sobrecarga Oral de Glucosa (PTGO con 75 g de glucosa). En individuos sanos, la hiperglicemia inducida actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis suprimiendo potentemente la liberación de hormona de crecimiento hasta valores menores a 1.0 mcg/L (o < 0.4 mcg/L en ensayos ultrasensibles). En los pacientes con acromegalia, el adenoma somatotropo posee autonomía funcional absoluta, demostrándose una falla patológica en la supresión de la GH (persiste ≥ 1.0 mcg/L).

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo**

1.03.1.014

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Es un síndrome de Sheehan clásico, que cursa con hipopituitarismo.

---

**PREGUNTA 86**

**Respuesta: B**

**Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo**

1.04.1.016

Dx: Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH) · Tx: Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina · Seg: Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH

GES

Una de las reglas más estrictas y evaluadas con mayor énfasis en el examen EUNACOM en relación al panhipopituitarismo es la secuencia cronológica mandatoria de reemplazo hormonal: SIEMPRE se deben administrar GLUCOCORTICOIDES (Hidrocortisona) ANTES de iniciar la hormona tiroidea (Levotiroxina). Si se administra levotiroxina a un paciente con déficit concomitante de ACTH/cortisol sin cobertura previa, la inducción del hipermetabolismo celular incrementa aceleradamente la degradación hepática y el aclaramiento del escaso cortisol plasmático residual, lo que desencadena de forma inmediata una Crisis Suprarrenal Aguda con shock circulatorio potencialmente letal.

---

**PREGUNTA 87**

**Respuesta: B**

**Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo**

1.04.1.016

Dx: Hormonas diana disminuidas (Cortisol, T4L, Estradiol/Testosterona) con tropinas hipofisarias bajas o 'inapropiadamente normales' (ACTH, TSH, LH/FSH) · Tx: Reemplazo hormonal escalonado. REGLA DE ORO DE SEGURIDAD: Iniciar SIEMPRE Glucocorticoides (Hidrocortisona) ANTES que Levotiroxina · Seg: Monitoreo clínico, densitometría ósea y ajuste periódico de dosis según bienestar, peso y presión arterial. NUNCA guiar levotiroxina con TSH

GES

En los pacientes con Hipotiroidismo Central (secundario o terciario por hipopituitarismo), la secreción hipofisaria de TSH se encuentra dañada de forma irreversible e intrínseca, por lo que los niveles séricos de TSH permanecerán siempre bajos, indetectables o inapropiadamente normales e independientes del estado tiroideo real del organismo. Por esta razón, la TSH carece por completo de utilidad clínica para monitorizar o titular la dosis de levotiroxina. El único parámetro biológico válido para evaluar la adecuación del tratamiento sustitutivo tiroideo en el hipopituitarismo es la concentración sérica de T4 LIBRE, debiendo ajustarse la dosis de levotiroxina para mantener la T4 libre en la mitad superior del rango normal de referencia.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: D**

**Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)**

1.03.1.015

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Diabetes insípida central

---

**PREGUNTA 89**

**Respuesta: B**

**Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)**

1.04.1.017

Dx: Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100) · Tx: DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d) · Seg: Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)

GES

El paciente presenta una Diabetes Insípida Central Aguda, complicación clásica y muy frecuente tras cirugías neuroquirúrgicas de la región selar o supraselar (como resección de craneofaringiomas o adenomas hipofisarios con manipulación del tallo hipofisario). La falta aguda de liberación de ADH provoca una incapacidad del túbulo colector para reabsorber agua libre, desencadenando poliuria hipotónica masiva (orinas muy diluidas con densidad < 1.005 y osmolaridad urinaria < 300 mOsm/kg) con hipernatremia resultante. La respuesta contundente a la administración de Desmopresina (aumento de la osmolaridad urinaria > 50-100% y colapso de la diuresis) confirma que el defecto radica en la falta central de hormona y no en una resistencia renal periférica.

---

**PREGUNTA 90**

**Respuesta: B**

**Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)**

1.04.1.017

Dx: Poliuria hipotónica: Osm urinaria < 300 mOsm/kg + Test de deprivación hídrica (Miller) y Desmopresina. Hiponatremia euvolémica: SIADH (Osm orina > 100) · Tx: DI Central: Desmopresina (DDAVP) nasal u oral. DI Nefrogénica: Hidroclorotiazida + Amilorida. SIADH: Restricción de fluidos (500-1000 mL/d) · Seg: Monitoreo estricto de sodio plasmático para evitar Síndrome de Desmielinización Osmótica (corrección máxima < 8-10 mEq/L en 24h)

GES

El cuadro clínico y la constelación familiar corresponden de manera inequívoca a un Síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (NEM 1 o Síndrome de Wermer). Este síndrome autosómico dominante está causado por mutaciones germinales inactivadoras en el gen supresor de tumores MEN1, ubicado en el cromosoma 11q13, el cual codifica para la proteína menina. Se caracteriza clínicamente por la presencia combinada de la clásica tríada de las 3 'P': 1) Paratiroides (hiperparatiroidismo primario en > 95% de los portadores); 2) Páncreas / tracto gastroenteropancreático (gastrinomas, insulinomas); y 3) Pituitaria o hipófisis anterior (prolactinomas y somatotropinomas). Las mutaciones del gen RET causan NEM 2A y 2B.

---

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 08 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# HÉMATO-ONCOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Hemostasia

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Hémato-oncología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES** | | | | | |
| 1.08.1.001 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q1, Q2, Q3, Q15, Q16 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 1.08.1.002 | Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14 | Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7) |
| 1.08.1.008 | Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17, Q18 | Tomo 08 · 8.5 (Pág. 17) |
| 1.08.1.015 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.016 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.017 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.008 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS** | | | | | |
| 1.08.1.003 | Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q19, Q20, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36 | Tomo 08 · 8.7 (Pág. 26) |
| 1.08.1.004 | Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28 | Tomo 08 · 8.6 (Pág. 22) |
| **BLOQUE 3: HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS** | | | | | |
| 1.08.1.005 | Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40, Q50, Q51 | Tomo 08 · 8.11 (Pág. 39) |
| 1.08.1.006 | Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44, Q45, Q46, Q47, Q48 | Tomo 08 · 8.13 (Pág. 45) |
| 1.08.1.012 | Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41, Q42, Q43 | Tomo 08 · 8.12 (Pág. 41) |
| 1.08.1.013 | Púrpuras vasculares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.001 | Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q53, Q54 | Tomo 08 · 8.15 (Pág. 51) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08.2.002 | Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q52 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.003 | Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q49 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.009 | Trombopenia severa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES** | | | | | |
| 1.08.1.007 | Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66, Q67, Q68, Q69 | Tomo 08 · 8.19 (Pág. 66) |
| 1.08.1.009 | Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q55, Q56, Q57, Q58, Q59 | Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56) |
| 1.08.1.010 | Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62 | Tomo 08 · 8.17 (Pág. 60) |
| 1.08.1.011 | Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 08 · 8.18 (Pág. 62) |
| 1.08.1.018 | Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71, Q72 | Tomo 08 · 8.20 (Pág. 68) |
| **BLOQUE 5: URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL** | | | | | |
| 1.08.1.014 | Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q88 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.019 | Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84, Q85, Q86, Q87 | Tomo 08 · 8.23 (Pág. 79) |
| 1.08.2.004 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76, Q77 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.005 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 08 · 8.22 (Pág. 77) |
| 1.08.2.006 | Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q73, Q74, Q75 | Tomo 08 · 8.21 (Pág. 73) |
| 1.08.2.007 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q83 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.3.005 | Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 08 · 8.24 (Pág. 81) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Hémato-oncología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08.1.001 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q1, Q2, Q3, Q15, Q16 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 1.08.1.002 | Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14 | Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7) |
| 1.08.1.003 | Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q19, Q20, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36 | Tomo 08 · 8.7 (Pág. 26) |
| 1.08.1.004 | Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28 | Tomo 08 · 8.6 (Pág. 22) |
| 1.08.1.005 | Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40, Q50, Q51 | Tomo 08 · 8.11 (Pág. 39) |
| 1.08.1.006 | Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44, Q45, Q46, Q47, Q48 | Tomo 08 · 8.13 (Pág. 45) |
| 1.08.1.007 | Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66, Q67, Q68, Q69 | Tomo 08 · 8.19 (Pág. 66) |
| 1.08.1.008 | Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17, Q18 | Tomo 08 · 8.5 (Pág. 17) |
| 1.08.1.009 | Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q55, Q56, Q57, Q58, Q59 | Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56) |
| 1.08.1.010 | Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62 | Tomo 08 · 8.17 (Pág. 60) |
| 1.08.1.011 | Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 08 · 8.18 (Pág. 62) |
| 1.08.1.012 | Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41, Q42, Q43 | Tomo 08 · 8.12 (Pág. 41) |
| 1.08.1.013 | Púrpuras vasculares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.014 | Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q88 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.015 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08.1.016 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.017 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.1.018 | Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71, Q72 | Tomo 08 · 8.20 (Pág. 68) |
| 1.08.1.019 | Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84, Q85, Q86, Q87 | Tomo 08 · 8.23 (Pág. 79) |
| 1.08.2.001 | Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q53, Q54 | Tomo 08 · 8.15 (Pág. 51) |
| 1.08.2.002 | Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q52 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.003 | Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q49 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.004 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76, Q77 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.005 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 08 · 8.22 (Pág. 77) |
| 1.08.2.006 | Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q73, Q74, Q75 | Tomo 08 · 8.21 (Pág. 73) |
| 1.08.2.007 | Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q83 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.008 | Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.2.009 | Trombopenia severa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 08 · Hematología (Pág. 8) |
| 1.08.3.005 | Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 08 · 8.24 (Pág. 81) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES

PREGUNTA 1 1.08.1.001

**1. Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento per- manente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotre- xate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatini- na de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm3, blancos 4.200/mm3 y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de fierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia por enfermedades crónicas
B) Mielodisplasia
C) Anemia por insuficiencia renal crónica
D) Hipoplasia medular
E) Mieloma múltiple

PREGUNTA 2 1.08.1.001

**2. 900 x mm3, VCM: 106 ft, HCM: 32 pg, VHS: 32 mm/h. Al frotis sólo destacan plaquetas disminuidas y macrocitosis leve. Al examen físico no se detectan otras alteraciones. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Iniciar vitamina 12 y folatos
C) Iniciar sulfato ferroso
D) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína
E) Solicitarde Coombs directo y haptoglobinayoncologia/ 4/6

PREGUNTA 3 1.08.1.001

**3. Un paciente con anemia normocítica normocrómica, se realiza exámenes que demuestran índice reticulocitario bajo, ferritina baja, ferremia baja y transferrina muy elevada. El diagnóstico más probable es:**

A) Mielodisplasia
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Anemia ferropénica
D) Hemocromatosis
E) Anemia hemolítica

PREGUNTA 4 1.08.1.015

**4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome leucoeritroblástico · 1.08.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome leucoeritroblástico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 1.08.1.016

**5. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome paraneoplásico · 1.08.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome paraneoplásico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 1.08.1.017

**6. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mielodisplásicos · 1.08.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mielodisplásicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 7 1.08.2.008

**7. Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax
B) Administrar diuréticos por vía endovenosa
C) Realizar quimioterapia de urgencia
D) Realizar radioterapia de urgencia
E) Realizar broncoscopía de urgencia

PREGUNTA 8 1.08.1.002

**8. Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico realizado hace un año, consulta por un cuadro de disnea e intolerancia al ejercicio, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina: 9,1 g/dl, hematocrito 28%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas 300.000 por mm3; ferritina plasmática: 9 ng/ml (VN: 12 – 150 ng/ml) y saturación de transferrina 12%. La conducta más adecuada es:**

A) Indicar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Administrar folatos orales
D) Administrar vitamina B12 por vía intra muscular
E) Transfundir glóbulos rojos

PREGUNTA 9 1.08.1.002

**9. La ferropénica se caracteriza por presentar:**

A) Ferritina disminuida y transferrina elevada
B) Ferritina aumentada y transferrina disminuida
C) Ferritina y transferrina aumentadas
D) Ferritina y transferrina disminuidas
E) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales

PREGUNTA 10 1.08.1.002

**10. La anemia ferropénica se caracteriza por presentar**

A) Elevación de la ferritina y de la transferrina
B) Elevación de la transferrina y disminución de la ferritina
C) Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina
D) Disminución de la ferritina y de la transaferrina
E) Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina

PREGUNTA 11 1.08.1.002

**11. Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Realizar una transfusión de glóbulos rojos
D) Administrar un uterotónico
E) Administrar ácido fólico y vitamina B12

PREGUNTA 12 1.08.1.002

**12. Un paciente de 71 años presenta un cuadro de dos meses de adinamia, astenia y disnea de medianos esfuerzos, progresiva. Al examen físico se observa importante palidez de piel y mucosas, por lo que se piden exámenes entre los que destacan hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,8 g/dl, VCM: 65 fl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 5.600 por mm3, frotis: microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis y anisocitosis, transferrina: 460 ug/dl y ferremia: 24 ug/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Realizar estudio endoscópico del tubo digestivo
C) Solicitar ferritina plasmática
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
E) Transfundir glóbulos rojos

PREGUNTA 13 1.08.1.002

**13. Un hombre de 57 años es diagnosticado de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:**

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía y endoscopía digestiva alta e indicar sulfato ferroso, controlando nuevo perfil de hierro en 6 meses
C) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

PREGUNTA 14 1.08.1.002

**14. Una mujer de 70 años es diagnosticada de anemia ferropénica, mediante un hemograma y un perfil de fierro. La conducta más adecuada es:**

A) Observar evolución
B) Solicitar colonoscopía e indicar sulfato ferroso oral
C) Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual
D) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional
E) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional

PREGUNTA 15 1.08.1.001

**15. El tratamiento de la anemia por enfermedades crónicas suele ser:**

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) El tratamiento de la enfermedad de base

PREGUNTA 16 1.08.1.001

**16. Un paciente con anemia normocítica se realiza un perfil de fierro que muestra ferremia baja, transferrina baja y ferritina elevada. El diagnóstico más probable es:**

A) Anemia hemolítica
B) Anemia por déficit de folatos
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Talasemia

PREGUNTA 17 1.08.1.008

**17. El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es:**

A) Transplante de médula ósea
B) Quimioterapia combinada
C) Radioterapiayoncologia/ 1/8
D) Cloramfenicol
E) No tiene tratamiento

PREGUNTA 18 1.08.1.008

**18. La causa más frecuente de aplasia medular es:**

A) Idiopática
B) Secundaria a fármacos
C) Secundaria a infecciones virales
D) Congénita
E) Invasión tumoral

## BLOQUE 2 ANEMIAS MACROCÍTICAS, HEMOLÍTICAS Y HEMOGLOBINOPATÍAS

PREGUNTA 19 1.08.1.003

**19. El tratamiento más eficaz del púrpura trombocitopénico trombótico es:**

A) Corticoides orales
B) Corticoides + inmunosupresores endovenosos
C) Soporte transfusional
D) Soporte dialítico + plasmaféresis
E) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa

PREGUNTA 20 1.08.1.003

**20. La anemia hemolítica presenta todo lo siguiente, EXCEPTO:**

A) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto
B) LDH muy aumentada
C) Presencia de esquistocitos
D) Elevación de la haptoglobina
E) Elevación de los reticulocitos

PREGUNTA 21 1.08.1.004

**21. Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 105.000 por mm3 y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mielodisplasia
B) Aplasia medular
C) Anemia por déficit de vitamina B12
D) Síndrome leucoeritroblástico
E) Anemia hemolítica autoinmune

PREGUNTA 22 1.08.1.004

**22. Una de estas causas produce anemia megaloblástica. Señálela:**

A) Pancreatectomía total.
B) Anemia perniciosa.
C) Gastrinoma.
D) Enfermedad de Cröhn.
E) Déficit de vitamina B1.

PREGUNTA 23 1.08.1.004

**23.** Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Anemia falciforme
B) Anemia perniciosa
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Anemia por déficit de vitamina B6

PREGUNTA 24 1.08.1.004

**24.** Adulto mayor con astenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, LDH elevada y VCM 123. ¿Diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Síndrome mielodisplásico
C) Anemia aplásica
D) Anemia megaloblástica
E) Linfoma no Hodgkin con compromiso medular

PREGUNTA 25 1.08.1.004

**25.** Un paciente de 71 años consulta por malestar general y disnea progresiva, que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen Fsico se observa pálido, con examen cardiopulmonar que muestra ritmo regular en dos 8empos, sin soplos, con frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto; y examen pulmonar que constata murmullo pulmonar simétrico sin otros ruidos. Se solicita hemograma que se informa con hematocrito: 16%, hemoglobina: 5,2 g/dL, VCM: 118 fL, CHCM: 40 g/dL, re8culocitos: 0,8%, plaquetas: 60.000/mm³ y glóbulos blancos: 3.300/mm³. Además, se solicita GOT: 52 U/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dL y bilirrubina directa: 0,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Anemia megaloblás2ca
B) Anemia aplásica
C) Anemia hemolí2ca
D) Mielodisplasia
E) Mielop2sis

PREGUNTA 26 1.08.1.004

**26.** Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm3, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Nivel de vitamina B12
B) Mielograma
C) Biopsia de médula ósea
D) Perfil de fierro
E) Prueba de Coombs

PREGUNTA 27 1.08.1.004

**27.** Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 57.000 por mm3 y, además, destaca LDH: 890 UI/L. EL diagnóstico más probable es:

A) Anemia aplástica
B) Anemia hemolítica
C) Anemia megalobástica
D) Mielodisplasia
E) Mieloma múltiple

PREGUNTA 28 1.08.1.004

**28.** Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm3, blancos: 3.200 por mm3. La indicación más adecuada es:

A) Ácido fólico
B) Vitamina B12
C) Fierro
D) Biopsia de médula ósea
E) Endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 29 1.08.1.003

**29.** Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen Fsico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el fro8s se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepá8cas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hepa22s A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

PREGUNTA 30 1.08.1.003

**30.** El tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune suele ser:

A) Eritropoyetina subcutánea
B) Transfusiones periódicas
C) Hierro y Folatos por vía oral
D) Corticoides
E) Trasplante de médula ósea

PREGUNTA 31 1.08.1.003

**31. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS compatible con una anemia hemolítica autoinmune?**

A) Prueba de coombs directa positiva
B) Haptoglobina bajayoncologia/ 1/6
C) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
D) Reticulocitos bajos
E) Macrocitosis

PREGUNTA 32 1.08.1.003

**32. Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:**

A) Haptoglobina
B) LDH
C) Coombs
D) Hemograma con reticulocitos
E) Bilirrubina total e indirecta

PREGUNTA 33 1.08.1.003

**33. Un paciente de 45 años, consulta por astenia, fiebre y orinas oscuras. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,6 g/dl, VCM: 110 ft, blancos: 8.000 x mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 169.000 x mm3. El frotis sanguíneo visualiza abundantes reticulocitos y esquistocitos. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar perfil de hierro
B) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos
C) Solicitar biopsia de médula ósea
D) Solicitars de coagulación
E) Solicitarde Coombs directo

PREGUNTA 34 1.08.1.003

**34. Paciente lúpica consulta por dolor abdominal, fiebre y orinas oscuras de 24 horas de evolución. Al examen se aprecia ictericia leve. En su analítica destaca hematocrito: 27%, plaquetas: 400.000, blancos: 11.400, bilirrubina de 4 mg/dl, de predominio indirecto, transaminasas normales, LDH:1070. La(s)(s) diagnóstica(s) para confirmar el diagnóstico es(son):**

A) Biopsia de médula ósea
B) Frotis de médula ósea
C) Orina completa y ecografía abdominal
D) C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra
E) Frotis sanguíneo yde coombs

PREGUNTA 35 1.08.1.003

**35. Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 mg/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia isocitosis y normalidad del índice de dispersión eritrocítica. Se solicita perfil de hierro que resulta normal. El diagnóstico más probable es:**

A) Talasemia
B) Anemia ferropénica
C) Anemia de enfermedades crónicas
D) Anemia hemolítica crónica
E) Hemocromatosis

PREGUNTA 36 1.08.1.003

**36. Una mujer de 36 años acude a la consulta como parte del control de su embarazo, de 20 semanas. El examen físico muestra los cambios normales del embarazo. Se toma hemograma, que demuestra Hematocrito: 33%, Hb: 11,2 g/dl, VCM:85, blancos y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es:**

A) Hemograma normal
B) Anemia ferropénica
C) Talasemiayoncologia/ 5/8
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Déficit de folatos

## BLOQUE 3 HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS

PREGUNTA 37 1.08.1.013

**37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Púrpuras vasculares · 1.08.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Púrpuras vasculares. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.08.2.009

**38. [URGENCIA: Trombopenia severa · 1.08.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trombopenia severa. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 1.08.1.005

**39. Un niño de 4 años ha presentado 2 hemartrosis de rodilla y varios episodios de hematomas profundos. Con alta probabilidad presentará:**

A) Alteración del recuento de plaquetas
B) Alteración de lass de agregación plaquetaria
C) Alteración de los niveles plamáticos de fibrinógeno
D) Alteración del TTPA
E) Alteración del TP

PREGUNTA 40 1.08.1.005

**40. Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. Usted esperaría encontrar:yoncologia/ 2/6**

A) Disminución del recuento de plaquetas
B) Alargamiento del tiempo de sangría
C) Alargamiento del TTPA
D) Disminución del fibrinógeno
E) Alargamiento del tiempo de protrombina

PREGUNTA 41 1.08.1.012

**41. Niño de 6 años previamente sano, sin medicamentos, consulta por púrpura petequial generalizada de inicio súbito posterior a infección viral. Plaquetas: 10.000/mm³. Resto del hemograma normal. Sin adenopatías ni visceromegalias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
B) Púrpura trombótica trombocitopénica
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Leucemia aguda linfoide

PREGUNTA 42 1.08.1.012

**42. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más orientador a una alteración de la hemostasia primaria?**

A) Alargamiento del TTPA
B) Equímosis
C) Antecedentes familiares de hemorragias
D) Petequias
E) Hemartrosis

PREGUNTA 43 1.08.1.012

**43. ¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un paciente de 55 años, sin antecedentes de interés, diagnosticado de púrpura trombocitopénica idiopática crónica, que no responde a esteroides tras 3 meses de terapia?:**

A) Azatioprina.
B) Danazol.
C) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis.
D) Vincristina.
E) Esplenectomía.

PREGUNTA 44 1.08.1.006

**44. Paciente con epistaxis, equimosis, gingivorragias frecuentes, antecedente familiar de epistaxis y menorragias, TTPA levemente prolongado. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Trombocitopenia inmune primaria (PTI)
B) Hemofilia A
C) Déficit de factor XI
D) Enfermedad de Von Willebrand
E) Coagulación intravascular diseminada (CID)

PREGUNTA 45 1.08.1.006

**45. ¿Cuál de los siguientes cuadros es más sugerente de una hemofilia?**

A) Paciente de sexo masculino y 16 años, que ha sufrido varias hemartrosis de rodillas y otras articulaciones, de manera espontánea
B) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes.
C) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia.yoncologia/ 5/7
D) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes.
E) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Respuestas: Prueba 5 HEMATOLOGÍA Preguntas Respuestas 1 A 2 D 3 C 4 C 5 E 6 E 7 E 8 C 9 A 10 D 11 B 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 D 18 A 19 D 20 Ayoncologia/ 6/7 Todos los Derechos Reservados para DrGuevarayoncologia/ 7/7

PREGUNTA 46 1.08.1.006

**46.** **Un niño de 6 años ha presentado varios hematomas musculares espontáneos y algunas hemartrosis a lo largo de su vida. La madre refiere que con frecuencia presenta equimosis ante traumas menores. El diagnóstico más probable es:**

A) Púrpura trombocitoénico inmune
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Hemofilia
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 47 1.08.1.006

**47.** **Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm3, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Glanzmann
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Déficit de factor VII
D) Hemofilia
E) Púrpura trombopénica inmune

PREGUNTA 48 1.08.1.006

**48.** **Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levemente alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Púrpura trombopénico inmune
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Factor V de Leiden

PREGUNTA 49 1.08.2.003

**49.** **[URGENCIA: Coagulopatía congénita sangrante · 1.08.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Coagulopatía congénita sangrante. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 50 1.08.1.005

**50.** **Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:**

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

PREGUNTA 51 1.08.1.005

**51.** **Las causas más frecuentes de daño hepático crónico en Chile son:**

A) Alcohol y hepatitis C
B) Alcohol y hepatitis B
C) Alcohol y tumoral 15gastroenterologia/ 4/8
D) Alcohol y NASH
E) Alcohol y autoinmune

PREGUNTA 52 1.08.2.002

**52.** **Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopía digestiva alta con urgencia, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Administrar vitamina K por vía endovenosa
B) Transfundir sangre completa
C) Administrar ácido tranexámico endovenoso
D) Administrar plasma fresco congelado endovenoso
E) Administrar factor VII recombinante endovenoso

PREGUNTA 53 1.08.2.001

**53.** **Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm3, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) ¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A) Crioprecipitado
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Sangre fresca
E) Plasma fresco congelado

PREGUNTA 54 1.08.2.001

**54.** **Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?**

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

## BLOQUE 4 ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES

PREGUNTA 55 1.08.1.009

**55.** **Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado gene- ral, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades infe- riores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probble?**

A) Leucemia aguda
B) Mononucleosis infecciosa
C) Linfoma
D) Síndrome hemolítico uremico
E) Coagulación intravascular diseminada

PREGUNTA 56 1.08.1.009

**56.** **Paciente de 50 años, consulta por astenia y fiebre ocasional, de 3 semanas de evolución. Al examen destaca esplenomegalia y palidez. El hemograma muestra Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl blancos: 43.000, con 5% de linfocitos y 95% de neutrófilos, con 10% segmentados, 0% baciliformes, 0% mielocitos, 74% promielocitos con aumento de cantidad de citoplasma, núcleo bilobulados, plegado, con abundantes gránulos y 6% de blastos. El diagnóstico más probable es:**

A) Leucemia mieloide crónica
B) Leucemia mieloide aguda
C) Mononucleosis infecciosa
D) Fiebre tifoídea
E) Mielodiplasia

PREGUNTA 57 1.08.1.009

**57.** **Un enfermo de 30 años, que consulta por cansancio, presenta un hemograma con una cifra de leucocitos de 4.800/microL y un porcentaje de blastos del 75%. Su diagnóstico es:**

A) Anemia refractaria con exceso de blastos.
B) Leucemia linfática crónica.
C) Leucemia mieloide aguda.
D) Leucemia mieloide crónica en fase crónica.
E) Leucemia mielomonocítica crónica.

PREGUNTA 58 1.08.1.009

**58.** **Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm3, plaquetas: 108.000 por mm3, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mielodisplasia
B) Mieloma múltiple
C) Anemia hemolítica
D) Anemia megaloblástica
E) Leucemia mieloide aguda

PREGUNTA 59 1.08.1.009

**59. Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma de Hodgkin
B) Leucemia mieloide aguda
C) Leucemia linfática aguda
D) Síndrome mononucleósico
E) Leucemia linfática crónica

PREGUNTA 60 1.08.1.010

**60. Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm3. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia aguda
B) Mielodisplasia
C) Leucemia mieloide crónica
D) Linfoma
E) Leucemia linfática crónica

PREGUNTA 61 1.08.1.010

**61. ¿Cuál de las siguientes patologías es un síndrome mielorpoliferativo?**

A) Linfoma
B) Leucemia de células peludas
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mieloptisis

PREGUNTA 62 1.08.1.010

**62. La asociación de leucocitosis elevada de predominio neutrofílico, desviación izquierda marcada y trombocitosis es característica de:**

A) Sepsis por bacterias Gram negativas
B) Reacción leucemoide
C) Leucemia aguda promielocítica
D) Leucemia aguda mielocítica
E) Leucemia crónica mieloide

PREGUNTA 63 1.08.1.011

**63. Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tuberculosis ganglionar
B) Linfoma
C) Infección por VIH
D) Sarcoidosis
E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 64 1.08.1.011

**64. Respecto a los linfomas de bajo grado, es FALSO que:**

A) La tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia, suele ser muy bajayoncologia/ 3/9
B) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados
C) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años
D) En los adultos mayores, suelen observarse
E) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares

PREGUNTA 65 1.08.1.011

**65. Los linfomas suelen derivarse de las siguientes alteraciones genéticas:**

A) Mutaciones autosómicas dominantes
B) Mutaciones autosómicas recesivas
C) Mutaciones ligadas al sexo
D) Translocaciones cromósómicas
E) Aneuploidías

PREGUNTA 66 1.08.1.007

**66. Pregunta 37 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8g/dl, VC;: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm3 y blancos: 5.800 por mm3, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Macroglobulinemia de Waldeström
B) Gamapatía monoclonal incierta
C) Mieloma múltiple
D) Amiloidosis
E) Enfermedad por cadenas pesadas

PREGUNTA 67 1.08.1.007

**67. Paciente de 65 años, con dolores óseos, presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:**

A) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
B) Anemia de enfermedades crónicas
C) Mieloma múltiple
D) Déficit de proteína C
E) Cáncer de próstatayoncologia/ 2/7

PREGUNTA 68 1.08.1.007

**68. Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS (Gamapatía monoclonal de significado incierto). La conducta más adecuada es:**

A) Obsevar evolución
B) Indicar quimioterapia
C) Iniciar ácido acetil salicílico
D) Iniciar hidroxiurea
E) Realizar trasnplante de médula ósea 13 ¿Cuáles de estos signos biológicos suelen observarse tanto en las anemias hemolíticas, como en las pérdidas de sangre por hemorragia?:

PREGUNTA 69 1.08.1.007

**69. Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:**

A) Mieloma múltiple
B) Cáncer prostático metastásico
C) Cáncer renal metastásico
D) Espondilodiscitis crónica
E) Espondilolistesis

PREGUNTA 70 1.08.1.018

**70. Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de aste- nia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos Al examen físico se apre- cia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6g/dL, blancos 4.200/mm3, plaque- tas 111.000/mm3 y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mieloptisis
B) Mieloma multiple
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis primaria

PREGUNTA 71 1.08.1.018

**71. Un paciente de 67 años, sin antecedentes de importancia se realiza exámenes de control, destacando un hemograma que demuestra hematocrito: 62%, hemoglobina: 20,6 g/dl, plaquetas: 500.000 por mm3, blancos: 7.800 por mm3, con fórmula diferencial normal. Al examen físico destaca esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:**

A) Hemograma normal
B) Anemia por enfermedades crónicas
C) Policitemia vera
D) Trombocitosis esencial
E) Poliglobulia por hipoxemia.

PREGUNTA 72 1.08.1.018

**72. Un paciente de 50 años consulta por poliglobulia, encontrada en un hemograma. Luego de un estudio acabado se concluye que padece de policitemia vera de bajo riesgo. El tratamiento más adecuado es:**

A) Eritropoyetina subcutánea y aspirina
B) Quimioterapia combinada y aspirina
C) Sangrías periódicas y aspirina
D) Anticoagulación oral a permanencia
E) Trasplante de médula óseayoncologia/ 2/8

## BLOQUE 5 URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

PREGUNTA 73 1.08.2.006

**73. Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Hemograma
B) Radiografía de tórax
C) Urocultivo
D) Ecografía abdominal
E) Mielograma

PREGUNTA 74 1.08.2.006

**74. Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequial generalizado. El examen más importante para confirmar la sospecha diagnóstica es:**

A) Hemograma con recuento de plaquetas
B) Hemocultivos
C) Pruebas de agregación plaquetaria
D) Tiempo de sangría
E) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada

PREGUNTA 75 1.08.2.006

**75.** **Un paciente con leucemia se realiza quimioterapia, evolucionando con una marcada neutropenia. Al 5 día post-quimioterapia presenta fiebre hasta 39°C. Usted sabe que la mayoría de las infecciones bacterianas en los pacientes neutropénicos febriles es causada por Pseudomona aureginosa y que de manera empírica debe ser tratado con doble cobertura para esta bacteria. ¿Qué combinación de antibióticos es más adecuada?**

A) Ceftriaxona + gentamicina
B) Piperacilina + vancomicina
C) Ciprofloxacino + metronidazol
D) Levofloxacino + clindamicina
E) Ceftazidina + amicacina

PREGUNTA 76 1.08.2.004

**76.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:**

A) Calcitonina
B) Solución salina al 0,9%
C) Vitamina D
D) Bifosfonatos
E) Corticoides

PREGUNTA 77 1.08.2.004

**77.** **Paciente con cáncer de próstata y calcio de 14 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico)
B) Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)
C) Calcitonina intranasal
D) Prednisona oral 40 mg/día
E) Diálisis de urgencia

PREGUNTA 78 1.08.2.005

**78.** **Un paciente de 55 años, diagnos8cado con un linfoma no Hodgkin con múl8ples masas medias`nicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm, inicia quimioterapia endovenosa. Al tercer día evoluciona con malestar general marcado, obnubilación y disnea. Al examen Fsico, se aprecia desorientado en el 8empo y el espacio, en malas condiciones generales y se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan ácido úrico: 13 mg/dL, sodio: 140 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, fósforo: 6,5 mg/dl, crea8nina plasmá8ca: 2,1 mg/dl y hematocrito 22%. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Hipercalcemia maligna
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome de vena cava superior
D) Síndrome de compresión medular
E) Síndrome de lisis tumoral

PREGUNTA 79 1.08.2.005

**79.** **El tratamiento de primera línea de la leucemia linfática aguda suele ser:**

A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos
B) Trasplante de médula ósea
C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención
D) Quimioterapia combinada de inducción sola
E) Exanguíneotransfusión y radioterapia

PREGUNTA 80 1.08.2.005

**80.** **El pronóstico de sobrevida de la leucemia linfática aguda de la infancia actualmente es aproximadamente:**

A) 85%
B) 60%
C) 30%
D) 10%
E) 2%

PREGUNTA 81 1.08.2.005

**81.** **Paciente con linfoma en quimioterapia. Post primer ciclo presenta hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Creatinina en ascenso. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Síndrome de lisis tumoral
B) Insuficiencia renal aguda prerenal
C) Nefrotoxicidad por cisplatino
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Hiperparatiroidismo secundario

PREGUNTA 82 1.08.2.005

**82.** **Paciente con leucocitosis, 80% blastos linfoides, hiperuricemia, hipocalcemia y fósforo límite alto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Quimioterapia de inducción inmediata
B) Rasburicasa e iniciar quimioterapia
C) Transfusión de glóbulos rojos y plaquetas
D) Hemodiálisis urgente
E) Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

PREGUNTA 83 1.08.2.007

**83. [URGENCIA: Síndrome de compresión medular · 1.08.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome de compresión medular. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 84 1.08.1.019

**84. Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Púrpura trombocitopénica trombótica
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 85 1.08.1.019

**85. ¿Cuál de las siguientes trombofilias congénitas es más severa?:**

A) Factor V de Leiden
B) Déficit de antitrombina III
C) Déficit de proteína C
D) Déficit de proteína S
E) Hiperhomocisteinemia

PREGUNTA 86 1.08.1.019

**86. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:**

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

PREGUNTA 87 1.08.1.019

**87. Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm3, blancos: 8.000 por mm3, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de antitrombina III
B) Hemofilia A
C) Trombofilia por anticoagulante lúpico
D) Hemofilia B
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 88 1.08.1.014

**88. [ATENCIÓN PRIMARIA: Reacción leucemoide · 1.08.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Reacción leucemoide. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 89 1.08.3.005

**89. ¿Qué grupo(s) de sangre puede recibir un paciente de grupo AB, que requiere de una transfusión, sin mayor riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico?**

A) Sólo AB
B) AB, A y B
C) O, A, B y AB
D) O y AB
E) A y B

PREGUNTA 90 1.08.3.005

**90. Un paciente de grupo sanguíneo A recibe una transfusión de glóbulos rojos AB. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente una reacción hemolítica tranfusional?**

A) Mayor al 95%yoncologia/ 3/8
B) 65%-95%
C) 35%-65%
D) 5%-35%
E) Menor al 5%

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 SÍNDROMES ANÉMICOS HIPOPROLIFERATIVOS Y CARENCIALES · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

Tanto por tener AR, como por la ferremia baja, con transferrina baja, orienta mu- cho a una anemia por enfermedades crónicas.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

La respuesta correcta es solicitar una biopsia de médula ósea. El paciente presenta trombocitopenia (plaquetas disminuidas) y macrocitosis leve (VCM elevado), con un recuento de glóbulos rojos que no se especifica pero implícitamente se asume dentro de la normalidad dado que no se menciona anemia. La elevación aislada del VCM sin anemia clara, junto con la trombocitopenia, puede ser indicativa de una patología medular subyacente que afecta la producción de todas las líneas celulares. La VHS elevada (32 mm/h) es un marcador inespecífico de inflamación, pero en el contexto de las alteraciones hematológicas, podría ser un signo de alarma. Ante la sospecha de una disfunción medular que no puede ser explicada por deficiencias nutricionales comunes o por hemólisis, la biopsia de médula ósea es el estudio de elección para evaluar la celularidad, la morfología de las células hematopoyéticas y descartar condiciones como síndromes mielodisplásicos, aplasia medular o infiltración neoplásica. Análisis de distractores: b) Iniciar vitamina B12 y folatos: Si bien la deficiencia de vitamina B12 o folatos causa macrocitosis, generalmente se asocia con anemia megaloblástica y otras citopenias. Sin embargo, la ausencia de anemia o de otras manifestaciones clínicas que sugieran estas deficiencias, sumado a la trombocitopenia, hace que iniciar este tratamiento empíricamente sin un diagnóstico sea precipitado. La biopsia de médula ósea permitirá confirmar o descartar estas deficiencias si se observan megaloblastos u otras alteraciones características. c) Iniciar sulfato ferroso: El sulfato ferroso se utiliza para tratar la anemia por deficiencia de hierro. La macrocitosis (VCM elevado) es opuesta a lo que se observa en la deficiencia de hierro, donde el VCM suele estar disminuido. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. d) Solicitar niveles plasmáticos de homocisteína: Los niveles elevados de homocisteína pueden estar asociados a deficiencia de vitamina B12 o folatos, pero solicitar este examen sin una sospecha clínica fuerte o como primera medida ante una trombocitopenia y macrocitosis no explicada, es menos preciso que evaluar directamente la médula ósea. e) Solicitar prueba de Coombs directo y haptoglobina: La prueba de Coombs directo se utiliza para detectar anemia hemolítica autoinmune, y la haptoglobina ayuda a evaluar la hemólisis. Dado que no hay evidencia de hemólisis en la descripción del caso (no se menciona anemia, ictericia, o hallazgos de laboratorio que sugieran hemólisis), estas pruebas no serían la prioridad ni la conducta más adecuada inicialmente.

### PREGUNTA 3 Respuesta: C

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

La anemia normocítica normocrómica indica que los glóbulos rojos tienen un tamaño y contenido de hemoglobina normales, lo que limita las opciones iniciales. El índice reticulocitario bajo sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la anemia, es decir, no está produciendo suficientes glóbulos rojos. La ferritina baja (depósitos de hierro disminuidos), la ferremia baja (hierro en sangre bajo) y la transferrina elevada (proteína transportadora de hierro aumentada) son hallazgos clásicos de anemia ferropénica. El cuerpo intenta compensar la falta de hierro aumentando la producción de transferrina para capturar la mayor cantidad de hierro posible. En resumen, la combinación de una anemia normocítica normocrómica con bajo índice reticulocitario y un perfil de hierro compatible con deficiencia (ferritina baja, ferremia baja y transferrina alta) apunta fuertemente a una anemia ferropénica en una fase inicial donde aún no se ha desarrollado la microcitosis e hipocromía típicas de la anemia ferropénica crónica. La anemia ferropénica es la causa más común de anemia en la práctica clínica. Análisis de distractores: * **a) Mielodisplasia:** La mielodisplasia es un síndrome donde la médula ósea no produce células sanguíneas normales. Aunque puede causar anemia, típicamente se asocia con citopenias en otras líneas celulares (leucopenia, trombocitopenia) y con reticulocitos normales o altos, además de frotis con displasia. El perfil de hierro no suele ser el de una ferropenia establecida. * **b) Anemia de enfermedades crónicas:** Esta anemia también suele ser normocítica normocrómica (aunque a veces puede ser microcítica), pero el perfil de hierro es distinto. La ferritina suele estar normal o alta (porque el hierro está atrapado en los macrófagos), la ferremia es baja y la transferrina es normal o baja. El índice reticulocitario suele ser bajo. * **d) Hemocromatosis:** Es una condición de sobrecarga de hierro. La ferritina y la ferremia estarían elevadas, y la transferrina estaría baja o normal. * **e) Anemia hemolítica:** Generalmente cursa con un aumento de reticulocitos (respuesta compensatoria de la médula ósea) y otros signos de hemólisis, como aumento de LDH y bilirrubina indirecta. El perfil de hierro no se ajusta a una ferropenia.

**PREGUNTA 4** **Respuesta: A**

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

1.08.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome leucoeritroblástico" (1.08.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 5** **Respuesta: A**

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

1.08.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome paraneoplásico" (1.08.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 6** **Respuesta: A**

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

1.08.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mielodisplásicos" (1.08.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: D**

**Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario**

1.08.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de vena cava superior: Caracterizado por obstrucción del flujo a través de la VCS con edema facial, distensión yugular, tos y disnea. En cáncer de células pequeñas, el tratamiento clásico es la radioterapia urgente (aunque actualmente se prefiere quimioterapia + stent).

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

**Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Anemia ferropénica con indicación de hierro endovenoso: El diagnóstico es una anemia moderada ferropénica, confirmada por la ferritina plasmática baja (reflejo de los depósitos de hierro) y la saturación de transferrina menor al 20%. La paciente requiere suplementación de hierro, y en este caso, la vía debe ser endovenosa debido a la cirugía de bypass gástrico, un factor de riesgo para la malabsorción de hierro, ya que se absorbe principalmente en el duodeno, por lo que las cirugías en esta área pueden afectar su absorción, similar a lo que ocurre en la enfermedad celíaca, donde el duodeno suele ser el segmento intestinal más afectado.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina**

La deficiencia de hierro (ferropénica) es la causa más común de anemia a nivel mundial. Se caracteriza por una disminución en las reservas de hierro del organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro en el cuerpo; por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, los niveles de ferritina sérica se encuentran bajos, reflejando la escasez de hierro almacenado. Por otro lado, la transferrina es la principal proteína transportadora de hierro en la sangre. Ante una disminución del hierro disponible, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina. Esto se debe a que la hepcidina, la hormona reguladora del hierro, disminuye en la ferropénica, lo que a su vez promueve la síntesis de transferrina en el hígado. Un aumento en la transferrina circulante permite captar de manera más eficiente el escaso hierro disponible en la dieta y transportarlo a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. La combinación de ferritina disminuida y transferrina elevada (o su índice, la capacidad total de fijación de hierro o TIBC, que estará aumentada) es el marcador bioquímico clásico de la ferropénica. Esta alteración refleja simultáneamente la depletedz de las reservas de hierro (baja ferritina) y el intento del organismo por movilizar y captar el hierro circulante (alta transferrina). Estos hallazgos son fundamentales para el diagnóstico diferencial de la anemia, distinguiéndola de otras causas como la anemia de enfermedad crónica o las anemias megaloblásticas. Análisis de distractores: b) Ferritina aumentada y transferrina disminuida: Esto sería característico de una sobrecarga de hierro o de un estado inflamatorio donde la transferrina se comporta como reactante de fase aguda negativo. c) Ferritina y transferrina aumentadas: La ferritina elevada suele indicar un aumento de las reservas de hierro o un estado inflamatorio/infeccioso. Si bien la transferrina podría estar aumentada en ciertos contextos, la combinación no es típica de ferropénica. d) Ferritina y transferrina disminuidas: La ferritina disminuida es típica de ferropénica, pero una transferrina disminuida no lo es; de hecho, el cuerpo intenta aumentarla. Podría verse una disminución conjunta en estados de malnutrición severa o enfermedad hepática crónica. e) Ferritina y transferrina dentro de rangos normales: Si bien es posible que en etapas muy tempranas de deficiencia de hierro estos valores estén normales, en la ferropénica establecida, estos parámetros están alterados.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina**

La anemia ferropénica se caracteriza por una deficiencia de hierro en el organismo. La ferritina es la principal proteína de almacenamiento de hierro, por lo tanto, en un estado de deficiencia de hierro, sus niveles disminuyen. La transferrina, por otro lado, es la proteína encargada de transportar el hierro en el plasma. Cuando hay deficiencia de hierro, el cuerpo intenta compensar aumentando la producción de transferrina para maximizar la captación de cualquier hierro disponible, resultando en una elevación de los niveles de transferrina. La saturación de transferrina (porcentaje de transferrina unida a hierro) también disminuye en la anemia ferropénica, aunque la pregunta se centra en los niveles absolutos de ferritina y transferrina. El aumento de la transferrina es una respuesta compensatoria para captar todo el hierro disponible, mientras que la ferritina refleja directamente el estado de los depósitos de hierro en el cuerpo. Análisis de distractores: a) **Elevación de la ferritina y de la transferrina:** La ferritina se eleva en estados de inflamación o sobrecarga de hierro, no en deficiencia. c) **Elevación de la ferritina y disminución de la transferrina:** Incorrecta por la misma razón que la opción a; la ferritina baja y la transferrina sube en anemia ferropénica. d) **Disminución de la ferritina y de la transaferrina:** La ferritina disminuye correctamente, pero la transferrina aumenta como respuesta compensatoria. e) **Disminución de la ferritina, aumento de la ferremia y disminución de la saturación de la tranferrina:** La ferremia (hierro sérico) puede estar normal o baja en la anemia ferropénica, pero no necesariamente aumentada. Si bien la saturación de transferrina disminuye, lo clave es la relación entre ferritina y transferrina, que esta opción confunde.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: A**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina**

Suplementación de Hierro en Anemia Posparto: En una paciente con anemia moderada secundaria a hemorragia posparto, se recomienda la suplementación con hierro para compensar las pérdidas, incluso si no se ha confirmado la deficiencia de hierro. La vía de administración puede ser oral o intravenosa. La vía oral suele ser suficiente para una recuperación completa, por lo que suele ser la de elección, mientras que la vía intravenosa ofrece una recuperación más rápida del hematocrito y es una alternativa del todo aceptable.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: E**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

**Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina**

Es una pregunta muy discutible, ya que tiene una clara anemia ferropénica, grave y se debe estudiar la presencia de cáncer digestivo, ya que es un adulto mayor. Sin embargo, probablemente sí se lo deba transfundir, ya que tiene una anemia muy sintomática. Por regla general, pero no absoluta, no se transfunden si tiene Hb mayor o igual a 10 g/dl y se suelen transfundir casi todos, si está menor a 7 g/dl. Entre 7 y 10, se ve caso a caso (aunque siempre se ve caso a caso). Dada la forma en que está redactada, recomiendo marcar la transfusión.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

**Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En un hombre de 57 años con diagnóstico de anemia ferropénica confirmada por hemograma y perfil de hierro, la conducta más adecuada es investigar la causa subyacente de la pérdida de hierro. A esta edad, la anemia ferropénica en hombres se asocia frecuentemente a pérdidas crónicas de sangre gastrointestinales, que pueden ser debidas a patologías como úlceras pépticas, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos o neoplasias. Por lo tanto, es fundamental realizar estudios endoscópicos como la endoscopía digestiva alta y la colonoscopía para identificar y tratar la fuente de sangrado. Paralelamente, se debe iniciar tratamiento con suplementos de hierro, como el sulfato ferroso, y monitorizar la respuesta hematológica y los niveles de hierro. El objetivo del tratamiento con sulfato ferroso es reponer las reservas de hierro y normalizar los parámetros hematológicos. Sin embargo, la duración del tratamiento no debe basarse únicamente en la normalización del hematocrito y la ferremia, ya que es crucial asegurar la corrección de la causa subyacente para prevenir recurrencias. El control periódico del perfil de hierro es necesario para evaluar la efectividad del tratamiento y la adecuada reposición de las reservas. Análisis de distractores: a) Observar la evolución: La anemia ferropénica, especialmente en un hombre de 57 años, requiere investigación activa de la causa subyacente y no simplemente observación, ya que podría enmascarar una patología grave. c) Indicar sulfato ferroso hasta normalizar el hematocrito y la ferremia: Si bien es necesario indicar sulfato ferroso, detener el tratamiento solo al normalizar estos parámetros sin investigar la causa es insuficiente. La anemia podría recurrir si la fuente de pérdida de hierro no se identifica y trata. d) Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Aunque 6 meses es un tiempo razonable para el tratamiento de la anemia ferropénica, omitir estudios adicionales en un hombre de 57 años es una omisión peligrosa, ya que se podría pasar por alto una causa importante de sangrado crónico. e) Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional: Un mes de tratamiento con sulfato ferroso es generalmente insuficiente para reponer las reservas de hierro y normalizar completamente los parámetros, y la omisión de estudios adicionales es inadecuada para un hombre en este grupo etario.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

**Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa**

1.08.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La anemia ferropénica en una mujer postmenopáusica (70 años) debe considerarse como un signo de alarma y obliga a descartar una causa subyacente, siendo la principal causa la pérdida de sangre gastrointestinal. La colonoscopía es el examen de elección para evaluar el colon y descartar patología tumoral, pólipos sangrantes u otras lesiones que puedan estar causando el sangrado crónico. El sulfato ferroso oral es el tratamiento de primera línea para reponer los depósitos de hierro una vez que se ha descartado la causa del sangrado o se está en proceso de investigación. La guía clínica del MINSAL de "Atención Integral de Salud de las Personas Adultas" hace hincapié en la importancia de investigar la causa de la anemia ferropénica en adultos mayores. Análisis de distractores: A: Observar evolución: Esta opción es incorrecta porque la anemia ferropénica en una paciente de 70 años requiere una investigación activa de la causa subyacente, no simplemente observación. Demorar la investigación podría retrasar el diagnóstico de una enfermedad grave, como un cáncer de colon. C: Indicar aporte oral de hierro, con hierro maltosado y solicitar recuento de reticulocitos mensual: Si bien el hierro maltosado es una alternativa al sulfato ferroso, esta opción ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente. Solicitar recuento de reticulocitos es útil para evaluar la respuesta al tratamiento, pero no aborda el problema principal: identificar la fuente de la deficiencia de hierro. D: Indicar sulfato ferroso por 6 meses sin necesidad de estudio adicional: Administrar hierro sin investigar la causa subyacente es un error grave. Podría enmascarar una patología importante y retrasar su diagnóstico. Se debe descartar sangrado digestivo antes de asumir que la anemia se debe a una simple deficiencia nutricional. E: Indicar sulfato ferroso por 1 mes sin necesidad de estudio adicional: Al igual que la opción D, esta es incorrecta porque ignora la necesidad de investigar la causa de la anemia en esta paciente. Un mes de tratamiento con hierro es insuficiente para resolver la deficiencia, y no aborda la causa del problema.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: E**

**Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, se caracteriza por una respuesta alterada a la eritropoyesis y una menor disponibilidad de hierro, secundaria a un proceso inflamatorio crónico. El mecanismo principal implica la acción de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), que interfieren con la producción de eritropoyetina, disminuyen la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina, aumentan la hepcidina (que bloquea la absorción y liberación de hierro) y acortan la vida útil de los glóbulos rojos. Por lo tanto, el abordaje terapéutico más efectivo y fundamental consiste en identificar y tratar la enfermedad de base que está generando la inflamación crónica. Al controlar o resolver la causa subyacente, se reduce la respuesta inflamatoria, se normalizan los niveles de hepcidina y se restaura la eritropoyesis eficaz. La resolución de la inflamación crónica permite que los mecanismos fisiológicos para la producción de glóbulos rojos se reanuden de manera adecuada. Esto implica una mejor absorción y utilización del hierro, una mayor sensibilidad de la médula ósea a la eritropoyetina endógena y una vida útil más prolongada de los eritrocitos. En muchos casos, una vez que la enfermedad de base está bien controlada, la anemia se resuelve espontáneamente o con medidas de soporte mínimas. Es crucial destacar que las otras opciones de tratamiento abordan síntomas o mecanismos específicos de la anemia, pero sin tratar la causa raíz, su eficacia es limitada y transitoria. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea: Si bien la eritropoyetina (EPO) puede ser útil en ciertos tipos de anemia, incluyendo algunas formas de AEC, su eficacia es limitada si la inflamación crónica persiste y los niveles de hepcidina son elevados. La EPO estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos, pero si el hierro no está disponible o la médula ósea está suprimida por la inflamación, el tratamiento será inefectivo o requerirá dosis muy elevadas. Por lo tanto, no es el tratamiento de primera línea ni el más fundamental. b) Transfusiones periódicas: Las transfusiones de glóbulos rojos son una medida de soporte para corregir rápidamente la anemia y sus síntomas, pero no tratan la causa subyacente. Son una opción en casos de anemia severa sintomática, pero no resuelven el problema de fondo y conllevan riesgos y costos asociados. No son el tratamiento habitual ni el principal para la AEC. c) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son cofactores esenciales para la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, en la AEC, la disponibilidad de hierro está comprometida por el aumento de la hepcidina. La suplementación oral de hierro puede ser ineficaz o de baja eficacia debido a la inhibición de su absorción. Si bien puede ser útil en algunos casos después de tratar la enfermedad de base o en presencia de deficiencia concomitante, no es el tratamiento primario. Los folatos, por su parte, son importantes pero la deficiencia de folato raramente es la causa principal de la AEC. d) Corticoides: Los corticoides son inmunosupresores y antiinflamatorios. Pueden ser útiles en anemias secundarias a enfermedades autoinmunes o inflamatorias específicas donde los corticoides son parte del tratamiento de esa patología. Sin embargo, no son un tratamiento generalizado para todas las anemias por enfermedades crónicas y su uso indiscriminado sin tratar la causa específica puede tener efectos secundarios importantes. No abordan directamente los mecanismos fisiopatológicos de la mayoría de las AEC.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: D**

**Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia por enfermedad crónica (AEC), también conocida como anemia de la inflamación, es la causa más común de anemia en pacientes hospitalizados y una de las más frecuentes en la población general. Se caracteriza por una anemia normocítica, aunque puede volverse microcítica en etapas avanzadas. El perfil de hierro describe una "ferremia baja" (hierro sérico bajo), "transferrina baja" (capacidad total de fijación de hierro o TIBC baja) y "ferritina elevada". Esta combinación es diagnóstica de AEC. La ferritina elevada indica que las reservas de hierro en el cuerpo son adecuadas o incluso altas; sin embargo, el hierro no está disponible para la eritropoyesis debido a la inflamación. Las citoquinas inflamatorias, como la interleucina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), inducen la producción hepática de hepcidina. La hepcidina es una hormona clave que regula el metabolismo del hierro, al degradar la ferroportina, la principal proteína transportadora de hierro en la membrana celular. Esto resulta en una menor liberación de hierro de los macrófagos y enterocitos hacia la circulación, lo que explica el hierro sérico bajo y la transferrina baja (ya que la transferrina se une al hierro disponible en sangre). A pesar del hierro sérico bajo, la ferritina está elevada porque es una proteína de fase aguda, incrementada por la inflamación, y refleja las reservas corporales de hierro en lugar de la disponibilidad para la eritropoyesis. Análisis de distractores: a) Anemia hemolítica: Se caracteriza por la destrucción prematura de los glóbulos rojos. El perfil de hierro típicamente mostraría niveles de hierro sérico elevados (debido a la liberación de hierro de los glóbulos rojos destruidos), ferritina normal o elevada, y transferrina normal o elevada. La bilirrubina indirecta también estaría elevada. b) Anemia por déficit de folatos: Es una anemia megaloblástica, por lo que los glóbulos rojos serían macrocíticos (VCM elevado). El perfil de hierro sería variable, pero no presentaría esta combinación específica de ferritina elevada con hierro y transferrina bajos. c) Anemia ferropénica: Se caracteriza por una deficiencia de hierro. El perfil de hierro mostraría típicamente hierro sérico bajo, transferrina alta (aumentada para intentar captar más hierro) y ferritina baja (reflejando las bajas reservas de hierro). Además, la anemia ferropénica suele ser microcítica (VCM bajo). e) Talasemia: Es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina. Las talasemias menores suelen cursar con anemia microcítica hipocrómica con un perfil de hierro normal. Las talasemias mayores pueden tener sobrecarga de hierro, pero la presentación clínica y los otros marcadores serían diferentes. El hierro sérico y la ferritina suelen ser elevados en formas severas de talasemia por transfusiones, pero la transferrina no se vería consistentemente baja.

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

1.08.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos**

La aplasia medular idiopática se caracteriza por la falla de la médula ósea en producir células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), lo que lleva a pancitopenia. El trasplante de médula ósea (TMO) alogénico, utilizando un donante compatible (idealmente un hermano HLA idéntico), es el tratamiento curativo de elección, especialmente en pacientes jóvenes. El TMO restaura la función hematopoyética normal al reemplazar las células madre defectuosas del paciente con células madre sanas del donante. En pacientes que no son elegibles para TMO (por edad, comorbilidades o falta de un donante compatible), o como puente al trasplante, se puede utilizar inmunosupresión con globulina antitimocítica (ATG) y ciclosporina, pero el TMO ofrece la mejor posibilidad de cura a largo plazo. Por lo tanto, el TMO es superior a las otras opciones terapéuticas en la mayoría de los casos de aplasia medular idiopática. Análisis de distractores: b) **Quimioterapia combinada:** La quimioterapia se utiliza para erradicar células malignas, pero no aborda la causa subyacente de la aplasia medular. De hecho, puede empeorar la condición al suprimir aún más la médula ósea. c) **Radioterapia:** La radioterapia también es un tratamiento para enfermedades malignas, no para la aplasia medular. Al igual que la quimioterapia, puede dañar aún más la médula ósea. d) **Cloramfenicol:** El cloramfenicol es un antibiótico que, paradójicamente, se ha asociado con aplasia medular en algunos casos. Por lo tanto, su uso estaría contraindicado. e) **No tiene tratamiento:** La aplasia medular idiopática sí tiene tratamiento, y el trasplante de médula ósea es el tratamiento más eficaz y curativo. Ignorar esta condición llevaría a complicaciones graves e incluso la muerte.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: A**

1.08.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos**

La respuesta correcta es la opción (a) Idiopática. La aplasia medular es una condición grave caracterizada por la insuficiencia de la médula ósea para producir suficientes células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). En la mayoría de los casos, la causa subyacente de la aplasia medular no puede ser identificada. A esto se refiere el término "idiopática", que significa de causa desconocida. Se estima que entre el 50% y el 75% de los casos de aplasia medular son idiopáticos. Aunque la aplasia medular puede ser secundaria a diversos factores, la etiología idiopática es, con diferencia, la más común. Se postula que estas formas idiopáticas podrían tener un origen autoinmune, donde el propio sistema inmunológico del paciente ataca y daña las células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Sin embargo, la confirmación definitiva de este mecanismo en todos los casos idiopáticos sigue siendo un área de investigación activa en hematología. Análisis de distractores: b) Secundaria a fármacos: Si bien algunos fármacos (como la quimioterapia, ciertos antibióticos o antiepilépticos) pueden causar supresión medular, no son la causa más frecuente de aplasia medular en general. La mayoría de los casos de aplasia medular no se asocian a la exposición a medicamentos. c) Secundaria a infecciones virales: Las infecciones virales, especialmente virus como el parvovirus B19, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus o la hepatitis, pueden estar asociadas a la aplasia medular en algunos casos. Sin embargo, la contribución de las infecciones virales a la etiología total de la aplasia medular es menor que la de los casos idiopáticos. d) Congénita: Las aplasias medulares congénitas, como la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita, son causas importantes en la población pediátrica, pero representan una minoría de todos los casos de aplasia medular a nivel global, siendo mucho menos comunes que las idiopáticas en adultos. e) Invasión tumoral: La infiltración de la médula ósea por células tumorales (metástasis o leucemias) puede llevar a una insuficiencia medular, pero esto se clasifica de manera diferente a la aplasia medular primaria. En la aplasia medular idiopática, la médula ósea está hipocelular y sin infiltración tumoral significativa.

---

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU**

El Púrpura Trombocitopénico Trombótico (PTT) es una microangiopatía trombótica grave, caracterizada por una deficiencia severa de la enzima ADAMTS13. Esta enzima es responsable de cortar los multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand (FvW). En su ausencia, estos multímeros se acumulan en la circulación, provocando la agregación plaquetaria espontánea y la formación de microtrombos en la microvasculatura de múltiples órganos, principalmente el cerebro y los riñones. Esto conduce a la péntada clásica (aunque no siempre completa) de trombocitopenia por consumo, anemia hemolítica microangiopática (con esquistocitos en el frotis de sangre), fiebre, disfunción neurológica e insuficiencia renal. La plasmaféresis (o recambio plasmático) es el tratamiento de elección y la medida más eficaz porque aborda directamente la fisiopatología de la enfermedad desde dos frentes. Primero, elimina del plasma del paciente los componentes patogénicos: los autoanticuerpos inhibidores de ADAMTS13 (en la forma autoinmune, que es la más común en adultos) y los multímeros ultragrandes del FvW. Segundo, al reponer el plasma extraído con plasma fresco congelado de donantes, se suministra la enzima ADAMTS13 funcional que el paciente no tiene. Este tratamiento debe iniciarse de forma urgente ante la sospecha clínica, ya que ha demostrado reducir la mortalidad del 90% a menos del 20%. La insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación frecuente y grave del PTT debido a la trombosis de la microvasculatura renal. Cuando la IRA es severa (oligoanuria, uremia, hiperkalemia refractaria o sobrecarga de volumen), el soporte dialítico se vuelve indispensable para mantener la homeostasis mientras la plasmaféresis resuelve la causa subyacente. Por lo tanto, la combinación de plasmaféresis (tratamiento específico) y soporte dialítico (tratamiento de soporte para la complicación más grave) constituye el manejo más completo y eficaz para un paciente con PTT grave. Análisis de distractores: **a) Corticoides orales:** Los corticoides son parte del tratamiento del PTT autoinmune, ya que ayudan a suprimir la producción de autoanticuerpos contra ADAMTS13. Sin embargo, su efecto no es inmediato y, como monoterapia, son insuficientes para controlar la fase aguda y potencialmente mortal de la enfermedad. Se utilizan como terapia adyuvante a la plasmaféresis, no como tratamiento principal. **b) Corticoides + inmunosupresores endovenosos:** Esta combinación (por ejemplo, con Rituximab) es una estrategia terapéutica importante, especialmente en casos refractarios o para prevenir recaídas. Al igual que los corticoides solos, su objetivo es suprimir la respuesta autoinmune, pero no es el tratamiento de primera línea más eficaz para la emergencia aguda, que requiere la eliminación inmediata de los factores patogénicos y la reposición de la enzima. **c) Soporte transfusional:** Aunque los pacientes presentan trombocitopenia severa, la transfusión de plaquetas está generalmente contraindicada. Se considera que "añade combustible al fuego", ya que las nuevas plaquetas pueden ser rápidamente consumidas en la formación de nuevos microtrombos, empeorando la isquemia tisular. Solo se considera en casos de hemorragia activa que ponga en riesgo la vida. La transfusión de glóbulos rojos sí es necesaria para manejar la anemia sintomática, pero es una medida de soporte, no el tratamiento de la enfermedad. **e) Reposición de agua y electrolitos por vía endovenosa:** Esta es una medida de soporte básico fundamental en cualquier paciente crítico, especialmente con insuficiencia renal. Sin embargo, no hace nada para tratar la causa subyacente del PTT. Es una terapia de sostén necesaria, pero de ninguna manera es el tratamiento más eficaz.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: D**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU**

La anemia hemolítica se caracteriza por una destrucción prematura de los glóbulos rojos (eritrocitos), lo que conduce a una serie de hallazgos de laboratorio. Uno de los mecanismos clave en la hemólisis es la liberación de hemoglobina en el plasma, que luego es metabolizada a bilirrubina. Dado que la hemoglobina se procesa principalmente en el hígado y el bazo, el aumento de la bilirrubina en la sangre tiende a ser predominantemente indirecta (no conjugada) antes de ser procesada por el hígado. La destrucción de eritrocitos también libera lactato deshidrogenasa (LDH), una enzima intracelular, que se eleva significativamente en la sangre como marcador de daño celular. Para compensar la pérdida de glóbulos rojos, la médula ósea aumenta la producción de nuevos eritrocitos, lo que se manifiesta como una elevación de los reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros. La presencia de esquistocitos, que son fragmentos de glóbulos rojos deformados, es característica de la hemólisis mecánica, que ocurre en ciertas anemias hemolíticas (como la coagulación intravascular diseminada o la microangiopatía trombótica). La haptoglobina es una proteína producida por el hígado que se une a la hemoglobina libre circulante. En condiciones normales, la hemoglobina liberada por la degradación fisiológica de los glóbulos rojos es captada por la haptoglobina. Sin embargo, en la anemia hemolítica, la cantidad de hemoglobina libre excede la capacidad de unión de la haptoglobina. Cuando los complejos haptoglobina-hemoglobina se forman en exceso, son rápidamente eliminados del torrente sanguíneo por el sistema reticuloendotelial. Por lo tanto, en la anemia hemolítica, los niveles de haptoglobina se encuentran disminuidos o indetectables debido a su consumo por la hemoglobina libre. Análisis de distractores: a) Bilirrubina elevada, de predominio indirecto: Incorrecta. Como se explicó, la destrucción de glóbulos rojos en la anemia hemolítica libera hemoglobina que se metaboliza a bilirrubina, siendo predominantemente indirecta. b) LDH muy aumentada: Incorrecta. La LDH es una enzima intracelular que se libera a la circulación cuando los glóbulos rojos se destruyen, por lo que se eleva significativamente en la anemia hemolítica. c) Presencia de esquistocitos: Incorrecta. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos que se observan al microscopio y son indicativos de hemólisis mecánica, un tipo de anemia hemolítica. e) Elevación de los reticulocitos: Incorrecta. La anemia hemolítica estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos para compensar la destrucción, lo que resulta en un aumento de los reticulocitos.

**PREGUNTA 21** **Respuesta: C**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tanto por la afectación neurológica, como por la pancitopenia con VCM tan elevado, es una anemia perniciosa, por déficit de B12.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La anemia megaloblástica es un tipo de anemia caracterizada por la presencia de eritrocitos (glóbulos rojos) anormalmente grandes (macrocitos) y precursores en la médula ósea también de gran tamaño (megaloblastos). Esto se debe fundamentalmente a una alteración en la síntesis de ADN durante la eritropoyesis, causada con mayor frecuencia por deficiencia de vitamina B12 (cobalamina) o folato. La anemia perniciosa es una causa específica de deficiencia de vitamina B12, donde el sistema inmunitario ataca las células parietales del estómago. Estas células son responsables de producir el factor intrínseco, una proteína esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon terminal. Sin factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe adecuadamente, lo que lleva a la anemia megaloblástica. Por lo tanto, la anemia perniciosa directamente causa la deficiencia de vitamina B12 necesaria para la síntesis normal de ADN en las células precursoras de la sangre, resultando en la anemia megaloblástica. Esta relación causa-efecto directa convierte a la anemia perniciosa en la respuesta correcta a la pregunta. Otras condiciones pueden contribuir a la deficiencia de B12 o folato, pero la anemia perniciosa es una causa clásica e intrínseca de deficiencia de B12 debido a la autoinmunidad contra las células parietales. Análisis de distractores: a) **Pancreatectomía total:** Si bien la pancreatectomía total puede afectar la absorción de nutrientes en general debido a la pérdida de enzimas pancreáticas, no es una causa directa ni común de anemia megaloblástica. La mala absorción de nutrientes, incluyendo folato, podría ocurrir, pero no es el mecanismo primario. c) **Gastrinoma:** Un gastrinoma es un tumor que secreta gastrina, lo que lleva a una hipersecreción de ácido gástrico. Esto puede causar úlceras pépticas severas, pero no afecta directamente la absorción de vitamina B12 ni folato. d) **Enfermedad de Crohn:** La enfermedad de Crohn puede causar anemia megaloblástica si afecta el íleon terminal, que es el sitio de absorción de la vitamina B12 en presencia del factor intrínseco. Sin embargo, no *produce* directamente la anemia megaloblástica; sino que la mala absorción secundaria a la enfermedad es la causa. Por lo tanto, si bien puede ser una causa indirecta, no es la respuesta más precisa. e) **Déficit de vitamina B1:** El déficit de vitamina B1 (tiamina) causa beriberi o síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son trastornos neurológicos. No causa anemia megaloblástica.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una anemia con VCM 110, es decir megaloblástica, por eso es por déficit de B12, causada en primer lugar por la anemia perniciosa. El déficit de folatos también podría ser una alternativa aceptable, pero los folatos son B9.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: D**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Anemia megaloblástica

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. El VCM tan elevado la sugiere fuertemente. Tanto anemia hemolítica como el déficit de B12 pueden tener VCM elevado, hiperbilirrubinemia indirecta y LDH elevada, pero los reGculocitos bajos son incompaGbles con una anemia hemolítica. Dada la gravedad que Gene, con hemoglobina bajo 7 g/dl, probablemente requiere de una transfusión de glóbulos rojos, además del tratamiento con vitamina B12 intramuscular. La causa más frecuente de déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, de origen autoinmune, con anticuerpos contra las células parietales gástricas, que hace que no se produzca el “factor intrínseco”, necesario para la absorción de B12. Por ello, se debe suplementar por vía intramuscular y no oral. En cambio, el déficit de B12 asociado a dietas vegetarianas y veganas sí se trata por vía oral.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: A**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene un déficit de B12, por baja ingesta (dieta vegana). La anemia macrocítica y megaloblástica (VCM > 108) la sugiere fuertemente.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: C**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es un clásico déficit de B12, con el compromiso neurológico y hematológico (pancitopenia, con VCM elevado). La LDH y la bilirrubina indirecta se elevan por la mielopoyesis inefectiva, al igual que en las anemias hemolíticas. Que el VCM sea mayor a 108 se conoce como anemia megaloblástica. Finalmente, la etiología más probable, en este caso, es una anemia perniciosa (enfermedad autoinmune contra las células parietales gástricas, que secretan el factor intrínseco, que permite la absorción de B12).

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

**Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato**

1.08.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Gastrectomía es la causa (falta factor intrínseco y no se absorve la B12). Tiene además la anemia megalobástica y la neuropatía, encefalopatía y probable degeneración combinada subaguda de la médula (todo causado por falta de B12).

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

**Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una anemia hemolítica clásica, probablemente autoinmune (AHAI). Orientan la anemia aguda y severa, con hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de LDH. El VCM se puede elevar, por aumento de los reGculocitos. Los microesferocitos se ven en la AHAI, por el daño que sufren los glóbulos; en cambio, la microesferocitosis familiar suele ser un cuadro crónico, menos grave, con esplenomegalia y exacerbación durante los cuadros agudos. La prueba de Coombs directo está positiva en la AHAI y negativa en la mayoría de las otras causas de hemólisis.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: D**

**Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la D) Corticoides. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es una condición donde el sistema inmunitario del individuo ataca y destruye sus propios glóbulos rojos. El tratamiento de primera línea para la AHAI, particularmente la variedad cálida (anticuerpos IgG), consiste en inmunosupresión. Los corticoides, como la prednisona, actúan suprimiendo la respuesta inmune y disminuyendo la producción de autoanticuerpos que causan la hemólisis. La dosis inicial suele ser alta y luego se reduce gradualmente según la respuesta del paciente. La base del tratamiento con corticoides reside en su capacidad de reducir la actividad del sistema reticuloendotelial, disminuyendo la captura y destrucción de los glóbulos rojos sensibilizados por autoanticuerpos en el bazo. Otros tratamientos, como la esplenectomía o el uso de inmunosupresores más potentes (rituximab, azatioprina, etc.), se reservan para casos refractarios a los corticoides. Análisis de distractores: A) Eritropoyetina subcutánea: La eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Si bien podría ayudar a compensar la anemia, no aborda la causa subyacente de la hemólisis (el ataque autoinmune) y sería ineficaz en presencia de una destrucción acelerada de glóbulos rojos. B) Transfusiones periódicas: Las transfusiones pueden ser necesarias para estabilizar al paciente en casos graves de anemia, pero son solo una medida de soporte y no tratan la causa de la hemólisis. Además, las transfusiones repetidas conllevan riesgos como la aloinmunización y la sobrecarga de hierro. C) Hierro y Folatos por vía oral: El hierro y los folatos son importantes para la producción de glóbulos rojos, pero no son el tratamiento principal para la AHAI. Aunque la hemólisis crónica puede llevar a la deficiencia de folato, la administración de hierro no es apropiada a menos que exista una deficiencia documentada, ya que en la AHAI la médula ósea está intentando producir glóbulos rojos a una velocidad acelerada y frecuentemente no hay carencia de hierro. E) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento agresivo que se reserva para casos muy raros y refractarios de AHAI, generalmente aquellos asociados a trastornos inmunitarios graves o cuando otras terapias han fallado. No es el tratamiento de primera línea.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: D**

**Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es (D) Reticulocitos bajos. En una anemia hemolítica autoinmune (AHAI), el cuerpo está destruyendo glóbulos rojos de forma acelerada. Como respuesta a esta destrucción, la médula ósea intenta compensar produciendo más glóbulos rojos. Por lo tanto, se espera encontrar un aumento en el número de reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, en la sangre periférica. Un recuento bajo de reticulocitos en el contexto de una anemia hemolítica sugiere que la médula ósea no está respondiendo adecuadamente a la demanda, lo cual es incompatible con la patogénesis de la AHAI. Análisis de distractores: a) Prueba de Coombs directa positiva: La prueba de Coombs directa es fundamental para el diagnóstico de AHAI. Detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos, lo que indica que están siendo atacados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, un Coombs directo positivo es altamente compatible con AHAI. b) Haptoglobina baja: La haptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre liberada durante la hemólisis. En la AHAI, la hemólisis intravascular y extravascular consume haptoglobina, lo que resulta en niveles bajos en sangre. Por lo tanto, la haptoglobina baja es compatible con AHAI. c) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto: La hemólisis produce un aumento en la degradación de la hemoglobina, generando bilirrubina. La mayor parte de esta bilirrubina es no conjugada (indirecta) antes de ser procesada en el hígado. Por lo tanto, la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto es una característica esperada en la AHAI. e) Macrocitosis: En muchas anemias hemolíticas, especialmente aquellas con una respuesta medular activa, los reticulocitos, que son más grandes que los glóbulos rojos maduros, pueden contribuir a un aumento del volumen corpuscular medio (VCM), resultando en macrocitosis. Si bien no es universal en todas las AHAI, es una alteración compatible.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: D**

**Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parece una anemia hemolítica. Si bien suelen no tener coluria (ya que la Bili es indirecta), puede que sea hemoglobinuria (también oscurece la orina). Se debe empezar con el hemograma y reticulocitos. Luego se pedirá el Coombs directo.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: E**

**Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de astenia, fiebre, orinas oscuras y palidez, junto con los hallazgos del hemograma (hematocrito bajo, hemoglobina baja, VCM elevado y abundantes reticulocitos y esquistocitos en el frotis) sugiere fuertemente una anemia hemolítica. Los esquistocitos, en particular, son fragmentos de glóbulos rojos que se forman cuando estos son destruidos mecánicamente en la circulación, lo cual es característico de la microangiopatía hemolítica. La presencia de reticulocitos elevados indica una respuesta medular aumentada a la pérdida de glóbulos rojos, lo que es consistente con hemólisis. La prueba de Coombs directo (PCD) es crucial en este escenario porque detecta anticuerpos o complemento adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, que son la causa subyacente de la hemólisis autoinmune. Un resultado positivo en la PCD orientaría hacia una anemia hemolítica autoinmune como causa principal, guiando el diagnóstico y tratamiento posterior. Análisis de distractores: a) Solicitar perfil de hierro: Si bien la deficiencia de hierro causa anemia, típicamente resulta en una anemia microcítica e hipocrómica (VCM bajo), lo cual no es el caso aquí ya que el VCM está elevado (macrocitosis). Por lo tanto, el perfil de hierro no es la prueba más urgente ni la que explicaría la presencia de esquistocitos. b) Solicitar niveles de vitamina B12 y folatos: Las deficiencias de vitamina B12 y folatos causan anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado, similar a este caso. Sin embargo, no explican la presencia de esquistocitos ni la hemólisis activa que parece estar ocurriendo. Aunque podrían ser causas de macrocitosis, la evidencia de hemólisis microangiopática hace que la PCD sea la prioridad. c) Solicitar biopsia de médula ósea: La biopsia de médula ósea es útil para evaluar la producción de células sanguíneas y diagnosticar trastornos de la médula ósea. Si bien podría ser necesaria en etapas posteriores del diagnóstico si la hemólisis no se explica por otras causas, no es la prueba inicial más adecuada ante la fuerte sospecha de hemólisis autoinmune, como lo indica la presencia de esquistocitos y la necesidad de determinar si hay anticuerpos. d) Solicitar pruebas de coagulación: Las pruebas de coagulación evalúan la cascada hemostática y los trastornos de la coagulación. Si bien una coagulopatía severa podría llevar a complicaciones hemorrágicas, no explica directamente la anemia hemolítica con esquistocitos. La presencia de esquistocitos apunta más a una destrucción mecánica de glóbulos rojos que a un problema de coagulación primaria, aunque condiciones como la Púrpura Trombocitopénica Trombotica (PTT) involucran tanto hemólisis como trombocitopenia y pueden tener alteraciones en la coagulación. Sin embargo, la PCD es el paso más directo para investigar la causa autoinmune de la hemólisis.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: E**

**Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica del paciente (lupus eritematoso sistémico, dolor abdominal, fiebre, orinas oscuras, ictericia, anemia, bilirrubina indirecta elevada y LDH elevada) sugiere fuertemente una hemólisis intravascular. La anemia con predominio de bilirrubina indirecta y LDH elevada apuntan a la destrucción de glóbulos rojos. En un paciente lúpico, la causa más probable de hemólisis es una anemia hemolítica autoinmune. Para confirmar este diagnóstico, es crucial determinar si los glóbulos rojos están siendo destruidos por anticuerpos. La prueba de Coombs (o prueba de antiglobulina directa) detecta anticuerpos o complemento unidos a la superficie de los glóbulos rojos. Un frotis sanguíneo puede revelar signos de hemólisis, como esquistocitos (fragmentos de glóbulos rojos) y esferocitos (glóbulos rojos esféricos sin la depresión central normal). La combinación de un frotis sanguíneo que muestre signos de hemólisis y una prueba de Coombs positiva confirmaría el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Análisis de distractores: a) **Biopsia de médula ósea:** Si bien la biopsia de médula ósea puede ser útil en el estudio de anemias, no es la prueba de primera línea para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune. Sería relevante si se sospechara falla medular o infiltración, pero no es lo que sugiere la clínica. b) **Frotis de médula ósea:** Similar a la biopsia, un frotis de médula ósea no es la prueba más directa para confirmar la hemólisis autoinmune. Aportaría información sobre la eritropoyesis. c) **Orina completa y ecografía abdominal:** La orina completa puede mostrar hemoglobinuria, lo que apoya la hemólisis, pero no confirma la etiología autoinmune. La ecografía abdominal se usaría para descartar otras causas de dolor abdominal, como colecistitis o esplenomegalia, pero no diagnostica la anemia hemolítica. d) **C3, C4 y anticuerpos anti-DNA doble hebra:** Si bien estos exámenes son importantes para el seguimiento del lupus y evaluar actividad de la enfermedad, no confirman directamente la anemia hemolítica autoinmune. Los niveles de complemento pueden estar disminuidos en lupus activo, pero no son específicos de la hemólisis.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: A**

**Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación del paciente con anemia microcítica (VCM 70) y un perfil de hierro normal, sumado a la presencia de isocitosis en el frotis de sangre periférica, apunta fuertemente hacia una talasemia. La isocitosis, que se refiere a la variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos, es un hallazgo característico en las talasemias, especialmente en las formas heterocigóticas o menores, donde la producción de cadenas de globina es deficiente, llevando a la formación de eritrocitos más pequeños y pálidos, pero con una población heterogénea. A diferencia de la anemia ferropénica, donde el VCM bajo se asocia a una disminución del hierro, aquí el perfil de hierro es normal, descartando la deficiencia como causa principal. La talasemia es un trastorno hereditario de la síntesis de hemoglobina que se manifiesta típicamente con anemia microcítica, incluso con niveles de hierro normales. La talasemia se clasifica según el tipo de cadena de globina afectada (alfa o beta). En la talasemia beta, hay una producción reducida o ausente de cadenas beta de globina, lo que lleva a un desequilibrio en la producción de hemoglobina A. En la talasemia alfa, hay una producción reducida o ausente de cadenas alfa de globina. Independientemente del tipo, el resultado es una producción de eritrocitos ineficiente y su destrucción prematura, llevando a la anemia. La isocitosis observada en el frotis refleja la heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos debido a los diversos grados de defecto en la síntesis de hemoglobina. Análisis de distractores: b) Anemia ferropénica: Incorrecta porque el perfil de hierro (que incluiría ferritina, hierro sérico, transferrina y saturación de transferrina) es normal. La anemia ferropénica se caracteriza por un VCM bajo debido a la falta de hierro para la síntesis de hemoglobina, y el perfil de hierro estaría alterado con bajos niveles de hierro y ferritina. c) Anemia de enfermedades crónicas: Incorrecta porque, aunque puede cursar con microcitosis, típicamente se asocia a un metabolismo del hierro alterado (aumento de ferritina con hierro sérico bajo o normal y saturación de transferrina baja), lo cual no se observa aquí. Además, la isocitosis es menos característica. d) Anemia hemolítica crónica: Incorrecta porque en la anemia hemolítica, si bien hay anemia, el VCM suele ser normal o aumentado (si hay reticulocitosis significativa), y el frotis típicamente mostraría esferocitos, acantocitos o fragmentos de glóbulos rojos, no isocitosis como hallazgo principal. Los índices de LDH y bilirrubina indirecta estarían elevados. e) Hemocromatosis: Incorrecta porque la hemocromatosis es una sobrecarga de hierro, lo que llevaría a un aumento del hierro y la ferritina sérica. El paciente no presenta anemia microcítica típicamente, sino que puede tener anemia normocítica o macrocítica en etapas avanzadas, y la causa subyacente es el exceso de hierro, no su deficiencia o defecto de síntesis de globina.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

1.08.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)**

La respuesta correcta es **a) Hemograma normal**. Durante el embarazo, el volumen plasmático aumenta en mayor proporción que la masa eritrocitaria, lo que conduce a una hemodilución fisiológica. Esto resulta en una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, incluso en ausencia de deficiencia de hierro. Los valores de hemoglobina de 11 g/dl y hematocrito de 33% se consideran normales para una mujer embarazada de 20 semanas. Es importante destacar que los rangos de referencia para los valores hematológicos varían durante el embarazo, y estos valores se encuentran dentro del rango aceptable. El VCM normal (85 fL) apoya aún más la idea de que no hay una deficiencia de hierro significativa o talasemia que esté afectando el tamaño de los glóbulos rojos. La ausencia de otros hallazgos clínicos o antecedentes que sugieran otras causas de anemia refuerza la conclusión de que los valores son consistentes con la hemodilución fisiológica del embarazo. Si bien es importante monitorizar los niveles de hierro durante el embarazo, los valores presentados no son lo suficientemente bajos como para diagnosticar anemia en este contexto. Por lo tanto, el hemograma se considera normal para el estadio del embarazo. Análisis de distractores: * **b) Anemia ferropénica:** Aunque la anemia ferropénica es común durante el embarazo, el VCM es normal (85 fL). En la anemia ferropénica, típicamente se esperaría un VCM bajo (microcítico). Además, aunque los niveles de Hb y Hto son bajos, están dentro del rango aceptable para el embarazo (normalmente >11 g/dL en el segundo trimestre). * **c) Talasemia:** La talasemia también suele presentar un VCM bajo (microcitosis), aunque en portadores talasémicos puede ser normal o discretamente bajo. Además, no hay indicios clínicos o antecedentes que sugieran talasemia. * **d) Anemia por enfermedades crónicas:** Generalmente, la anemia por enfermedades crónicas se acompaña de otros hallazgos clínicos relacionados con la enfermedad subyacente, que no están presentes en este caso. El VCM puede ser normal o bajo, y no hay evidencia de una enfermedad crónica. * **e) Déficit de folatos:** El déficit de folatos causa anemia megaloblástica, que se caracteriza por un VCM elevado (macrocítico). El VCM normal en este caso descarta esta posibilidad.

---

## BLOQUE 3 HEMOSTASIA PRIMARIA, PLAQUETAS Y COAGULOPATÍAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Púrpuras vasculares**

1.08.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Púrpuras vasculares" (1.08.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A** **Trombopenia severa**

1.08.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trombopenia severa" como urgencia clínica (1.08.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: D**

**Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno**

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presentación de hemartrosis recurrentes (sangrado en las articulaciones) y hematomas profundos en un niño de 4 años es altamente sugestiva de un trastorno de la coagulación, específicamente un defecto en la vía intrínseca de la cascada de coagulación. El tiempo de protrombina activado (TTPA) es una prueba de laboratorio que evalúa precisamente la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. Un TTPA prolongado indica una deficiencia o disfunción de uno o más factores de coagulación involucrados en estas vías. Las hemartrosis son una manifestación clásica de trastornos severos de la coagulación, como la hemofilia A (deficiencia del factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia del factor IX), ambos de herencia ligada al cromosoma X y que cursan con un TTPA prolongado y un TP normal. Por lo tanto, con alta probabilidad, este niño presentará una alteración del TTPA debido a una deficiencia en la vía intrínseca de la coagulación, lo que conduce a su tendencia a sangrar excesivamente en articulaciones y tejidos profundos. Es importante destacar que aunque el tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca y la vía común, en las hemofilias típicas el TP suele ser normal. Las plaquetas y su función, así como el fibrinógeno, son evaluados por otras pruebas y, aunque pueden verse afectados secundariamente en algunas coagulopatías severas, la alteración primaria que explica estas manifestaciones clínicas se encuentra en los factores de coagulación medidos por el TTPA. Análisis de distractores: a) Alteración del recuento de plaquetas: Un recuento plaquetario anormal, como la trombocitopenia (bajo número de plaquetas) o la trombocitosis (alto número de plaquetas), causa principalmente sangrado a nivel cutáneo y de mucosas (petequias, púrpura), o trombosis en el caso de la trombocitosis. No son la causa principal de hemartrosis recurrente y hematomas profundos sin otras alteraciones plaquetarias evidentes. b) Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria: Problemas en la agregación plaquetaria se manifiestan con sangrados de tipo petequial o equimótico superficial, sangrado de mucosas y prolongación del tiempo de sangría. Si bien pueden contribuir a un sangrado generalizado, no son la causa primaria de las hemartrosis severas que sugieren un defecto en la cascada de coagulación. c) Alteración de los niveles plasmáticos de fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es fundamental en la vía común de la coagulación para formar el coágulo de fibrina. Niveles muy bajos de fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causan sangrado severo generalizado, incluyendo hemartrosis, pero se clasificarían dentro de las coagulopatías, y la prueba más sensible para detectar déficits en la vía intrínseca y común es el TTPA. Además, otras coagulopatías con TTPA prolongado son mucho más comunes. e) Alteración del TP: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca (factores VII) y la vía común (factores X, V, II, I). Un TP alterado sugiere deficiencias en estos factores, como se ve en la deficiencia de vitamina K, anticoagulación con warfarina, o coagulopatías como la deficiencia de factor VII. Las hemartrosis severas y la historia del niño son más características de déficits en la vía intrínseca, lo que lleva a un TTPA prolongado y un TP normal (en la mayoría de los casos de hemofilia).

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

**Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno**

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presentación de hematomas musculares espontáneos y hemartrosis recurrentes en un niño de 6 años, junto con equimosis ante traumas menores, sugiere una diátesis hemorrágica hereditaria. La respuesta correcta, el alargamiento del TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada), apunta hacia un defecto en la vía intrínseca o común de la cascada de coagulación. Las hemofilias (A y B) son las causas más comunes de hemorragias significativas en niños y se caracterizan por deficiencias en los factores VIII y IX, respectivamente. Ambos factores participan en la vía intrínseca de la coagulación, y su deficiencia resulta en un TTPA prolongado mientras que el tiempo de protrombina (TP), que evalúa la vía extrínseca, y el tiempo de sangría suelen ser normales. El TTPA evalúa la función de los factores de coagulación de la vía intrínseca (factores XII, XI, IX, VIII) y de la vía común (factores X, V, II, I). Un TTPA prolongado indica una anomalía en uno o más de estos factores. Dada la clínica de hemorragias profundas (hematomas, hemartrosis), la principal sospecha recae en las hemofilias. En estas patologías, la vía extrínseca (evaluada por el TP) y la hemostasia primaria (evaluada por el tiempo de sangría y el recuento plaquetario) son generalmente normales, lo que descarta otras causas de sangrado. Por lo tanto, el alargamiento del TTPA es el hallazgo más probable en este escenario clínico. Análisis de distractores: a) Disminución del recuento de plaquetas: Un recuento bajo de plaquetas (trombocitopenia) o una disfunción plaquetaria se manifestarían típicamente con sangrado de mucosas, petequias y equimosis en piel, que son más superficiales. Los hematomas musculares y las hemartrosis son menos comunes en trombocitopenias puras y más sugestivos de defectos en la coagulación. b) Alargamiento del tiempo de sangría: El tiempo de sangría es una medida de la hemostasia primaria, que depende de la función plaquetaria y la integridad de los vasos sanguíneos. Un tiempo de sangría prolongado se observa en trastornos plaquetarios o enfermedad de von Willebrand, pero no es la alteración principal en las hemofilias, que afectan la coagulación. d) Disminución del fibrinógeno: El fibrinógeno (factor I) es crucial para la formación del coágulo final. Una disminución severa del fibrinógeno (afibrinogenemia o hipofibrinogenemia) causaría un sangrado generalizado y prolongado. Sin embargo, las hemofilias no afectan directamente los niveles de fibrinógeno, sino los factores que activan la trombina, que a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina. e) Alargamiento del tiempo de protrombina: El tiempo de protrombina (TP) evalúa la vía extrínseca de la coagulación (factores VII, X, V, II, I). Un TP prolongado sugiere un defecto en estos factores, como en la deficiencia de vitamina K, enfermedad hepática o deficiencia del factor VII. Las hemofilias afectan principalmente la vía intrínseca, dejando el TP generalmente normal.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

**Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES**

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

PTI: trombocitopenia aislada severa en niño sano post-viral, sin anemia hemolítica ni IRA (descarta SHU/PTT), sin blastos (descarta leucemia). El PTI pediátrico es autolimitado en el 80% en 6 meses. Tratamiento: observación si asintomático, IGIV o corticoides si hay sangrado.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: D**

**Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES**

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Las petequias son pequeñas hemorragias puntiformes, menores a 3 mm, que se producen por la extravasación de sangre desde los capilares. Su presencia es altamente sugestiva de una alteración en la hemostasia primaria, que es el proceso inicial de formación del tapón plaquetario. Las causas de petequias incluyen trombocitopenia (disminución del número de plaquetas), disfunción plaquetaria, vasculitis o fragilidad capilar. La guía GES Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del MINSAL, por ejemplo, destaca las petequias como un hallazgo común en pacientes con trombocitopenia. Análisis de distractores: * **A: Alargamiento del TTPA:** El Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA) evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación. Su alargamiento sugiere deficiencias en factores de coagulación como el VIII, IX, XI o XII, o la presencia de anticoagulantes lúpicos, apuntando a un problema en la hemostasia secundaria (coagulación), no primaria. * **B: Equímosis:** Las equímosis son hematomas más grandes, mayores a 1 cm, que también implican extravasación de sangre. Si bien pueden estar presentes en alteraciones de la hemostasia primaria (especialmente si son de aparición fácil y espontánea), también son comunes en alteraciones de la hemostasia secundaria y traumatismos. No son tan específicas para hemostasia primaria como las petequias. * **C: Antecedentes familiares de hemorragias:** Si bien los antecedentes familiares pueden sugerir un trastorno hemorrágico hereditario, no orientan específicamente a una alteración de la hemostasia primaria. Podrían indicar hemofilias (alteración de la hemostasia secundaria), enfermedad de von Willebrand (que afecta la función plaquetaria y al factor VIII), u otros trastornos. * **E: Hemartrosis:** La hemartrosis (sangrado intraarticular) es muy característica de las hemofilias, un trastorno de la hemostasia secundaria debido a la deficiencia de factores de coagulación (VIII o IX). No es un hallazgo típico de la alteración de la hemostasia primaria.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: E**

**Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES**

1.08.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

En un paciente con Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) crónica, de 55 años, que no responde a un tratamiento de 3 meses con esteroides, se considera la esplenectomía como la segunda línea de tratamiento de elección. La PTI crónica se caracteriza por la destrucción periférica de plaquetas mediada por anticuerpos. Los esteroides son la terapia de primera línea, pero en caso de refractariedad o dependencia, se deben considerar otras opciones. La esplenectomía, al extirpar el principal sitio de destrucción de plaquetas y el lugar de producción de anticuerpos, puede lograr una remisión sostenida en un alto porcentaje de pacientes. La decisión de la esplenectomía como segunda línea se basa en su eficacia y en la posibilidad de evitar tratamientos inmunosupresores crónicos que pueden tener efectos adversos significativos a largo plazo. Si bien existen otras opciones farmacológicas, la remisión obtenida con la esplenectomía suele ser más duradera y a menudo permite suspender la medicación. Es importante destacar que la esplenectomía debe ir acompañada de profilaxis contra infecciones encapsuladas debido al riesgo incrementado de sepsis post-esplenectomía. Análisis de distractores: a) Azatioprina: La azatioprina es un inmunosupresor que se utiliza como terapia de segunda o tercera línea en la PTI, pero generalmente después de considerar la esplenectomía o en pacientes en quienes la esplenectomía no es una opción viable. Su eficacia puede ser menor que la de la esplenectomía y requiere un seguimiento cuidadoso por sus efectos secundarios. b) Danazol: El danazol es un andrógeno sintético que puede ser útil en la PTI, particularmente en mujeres, pero no es la primera opción de segunda línea en un paciente refractario a esteroides. Su mecanismo de acción es complejo e incluye la supresión de la médula ósea y la reducción de la sensibilidad de los macrófagos a los anticuerpos. c) Inmunoglobulinas i.v. a altas dosis: Las inmunoglobulinas intravenosas (IVIg) se utilizan principalmente para aumentar rápidamente el recuento de plaquetas en situaciones agudas de sangrado o para preparaciones pre-esplenectomía. No son una terapia de segunda línea para la PTI crónica refractaria a esteroides, ya que su efecto es transitorio y su uso crónico es costoso y menos eficaz que otras opciones. d) Vincristina: La vincristina es un agente quimioterapéutico que puede utilizarse en la PTI, a menudo en combinación con otros fármacos o en casos dePTI severa o refractaria. Sin embargo, su uso como segunda línea de tratamiento aislado en la PTI crónica refractaria a esteroides no es la opción estándar, y su toxicidad puede ser una preocupación.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: D**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfermedad de Von Willebrand

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por la deficiencia de factores de coagulación específicos, principalmente el factor VIII (hemofilia A) o el factor IX (hemofilia B). La presentación clínica más clásica y sugestiva de hemofilia en un paciente masculino de 16 años es la presencia de hemartrosis (sangrado dentro de las articulaciones), especialmente en articulaciones de carga como las rodillas, de manera espontánea o tras traumatismos mínimos. Estas hemartrosis recurrentes pueden llevar a dolor crónico, inflamación y, a largo plazo, a daño articular severo, deformidades y limitación funcional. La edad de 16 años es común para que estas manifestaciones se vuelvan evidentes, dado que la acumulación de sangrados articulares se hace clínicamente significativa. La naturaleza espontánea de las hemartrosis es un hallazgo clave que distingue a la hemofilia de otros trastornos de la coagulación o plaquetarios. Si bien los traumatismos mínimos pueden desencadenar sangrado, la recurrencia sin un trauma aparente o con un trauma muy leve es altamente indicativa de una deficiencia severa de factores de coagulación. La afectación exclusiva o predominante de hombres, debido a la herencia ligada al cromosoma X, también refuerza la sospecha diagnóstica en este caso. Análisis de distractores: b) Paciente de sexo masculino y 14 años, que presenta epistaxis frecuentes, asociado a aparición de petequias y equimosis con pequeños golpes. Esta descripción es más sugestiva de un trastorno plaquetario (como trombocitopenia o disfunción plaquetaria) o de una coagulopatía adquirida que afecte la hemostasia primaria. Las petequias son sangrados puntiformes superficiales, característicos de problemas plaquetarios o vasculares. La hemofilia, al ser un defecto en la cascada de coagulación (hemostasia secundaria), se manifiesta típicamente con hematomas grandes (equimosis), sangrado profundo en articulaciones y músculos, y sangrados prolongados después de cortes o procedimientos, no tanto con petequias. c) Paciente de sexo femenino de 13 años, que presenta hematuria y artralgias, asociado a un púrpura de extremidades inferiores y hematoquezia. Si bien una paciente femenina podría ser portadora de hemofilia (lo que a veces puede causar síntomas leves), la combinación de hematuria, artralgias, púrpura y hematoquezia es más compatible con enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, que puede causar vasculitis y manifestaciones hematológicas), o con otras coagulopatías hereditarias menos comunes o adquiridas. Las artralgias son inespecíficas y pueden ocurrir en diversas condiciones. El púrpura puede ser de origen plaquetario, vascular o inducido por vasculitis. La hematuria y hematoquezia también pueden tener múltiples causas, incluyendo coagulopatías, pero la presentación completa no es la típica de hemofilia. d) Paciente de sexo femenino, de 18 años, que desde su infancia ha prensentado tendencia a presentar equimosis, sangra más de lo normal en procedimientos dentales y tiene reglas muy abundantes. Aunque las mujeres pueden ser portadoras de hemofilia y en raras ocasiones tener niveles de factor de coagulación lo suficientemente bajos como para presentar síntomas, esta descripción es más común en portadoras sintomáticas de hemofilia A o B, o en pacientes con enfermedad de von Willebrand (una de las coagulopatías hereditarias más comunes y que afecta a ambos sexos, con manifestaciones variables). Las reglas muy abundantes (menorragia) y la tendencia a equimosis son síntomas compatibles con trastornos de la hemostasia, pero la hemofilia clásica se presenta predominantemente en varones con hemartrosis profundas. e) Paciente de sexo masculino, de 5 años, que presenta un púrpura petequial generalizado, de 3 días de evolución, que empezó una semana después de una infección respiratoria alta. Este cuadro es altamente sugestivo de una Trombocitopenia Inmunológica (PTI) post-infecciosa en un niño. La PTI se caracteriza por la destrucción de plaquetas, lo que lleva a sangrado superficial en forma de petequias y equimosis. La aparición después de una infección viral es un antecedente típico de PTI. La hemofilia, en cambio, no se asocia típicamente con infecciones virales desencadenantes y su manifestación principal no son las petequias generalizadas.

**PREGUNTA 46** **Respuesta:**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es Hemofilia. Los hematomas musculares espontáneos, las hemartrosis (sangrado en las articulaciones) y las equimosis fáciles ante traumas menores son características clásicas de la hemofilia, especialmente la hemofilia A (deficiencia de factor VIII) o la hemofilia B (deficiencia de factor IX). Estas enfermedades son hereditarias y afectan principalmente a varones, quienes heredan el cromosoma X afectado de sus madres portadoras. La gravedad de los síntomas varía dependiendo del nivel de factor de coagulación deficiente. La presentación a temprana edad, como en este niño de 6 años, es común en casos de hemofilia moderada a severa. La hemofilia se debe a una deficiencia en uno de los factores de coagulación necesarios para la formación del coágulo sanguíneo. Esta deficiencia conduce a una coagulación ineficaz y, por lo tanto, a sangrado prolongado o espontáneo. Las hemartrosis repetidas pueden causar daño articular crónico y discapacidad a largo plazo si no se tratan adecuadamente. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio que miden los niveles de factores de coagulación VIII y IX. Análisis de distractores: * **Púrpura trombocitoénico inmune (PTI):** Si bien el PTI causa sangrado, generalmente se manifiesta con petequias, púrpura (manchas pequeñas de sangrado en la piel) y sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival). Las hemartrosis son raras en PTI. El PTI se caracteriza por una disminución del número de plaquetas, lo cual no se menciona en el caso. * **Púrpura trombocitopénico trombótico (PTT):** El PTT es una emergencia médica rara que implica la formación de microtrombos en los vasos sanguíneos, lo que conduce a trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y disfunción orgánica. Se caracteriza por fiebre, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal y anemia. No encaja con la presentación clínica del caso. * **Coagulación intravascular diseminada (CID):** La CID es un trastorno de la coagulación generalizado que se produce como complicación de otras enfermedades subyacentes graves (sepsis, traumatismos graves, cáncer). Implica la activación generalizada de la coagulación y la fibrinólisis, lo que lleva tanto a trombosis como a sangrado. No se presenta de forma espontánea en un niño sano. * **Enfermedad de Von Willebrand (EVW):** La EVW es un trastorno hemorrágico hereditario común que afecta la función del factor de Von Willebrand, que es importante para la adhesión de las plaquetas y el transporte del factor VIII. Generalmente se manifiesta con sangrado mucocutáneo (sangrado nasal, gingival, menstruaciones abundantes), pero las hemartrosis son menos comunes que en la hemofilia severa. La EVW suele diagnosticarse en la adolescencia o en la edad adulta, aunque a veces se puede presentar en la infancia.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una EvW clásico (alteración de hemostasia primaria: petequias y alveolorragia), con plaquetas normales (es disfunción plaquetaria) y puede alargar levemente el TTPA. La hemofilia alarga el TTPA pero tendría muchos más síntomas y hematomas, además de hemartrosis y sin petequias.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra “leve” orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tenr hematomas y tipo 3 se caracteriza por tenerlos. Un caso como este está límite entre ambas. La hemofilia probablemente sería más grave, con síntomas desde la infancia y con hemartrosis y más hematomas.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: A**

**Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand**

1.08.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Coagulopatía congénita sangrante" como urgencia clínica (1.08.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

**Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes**

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente. La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT. Análisis de distractores: **b) Sustituiría la aspirina por clopidogrel:** El clopidogrel es un antiplaquetario, y la terapia antiplaquetaria es inferior a la anticoagulación oral para la prevención de eventos cardioembólicos en pacientes con FA de alto riesgo. **c) Añadiría clopidogrel a la aspirina:** La terapia antiplaquetaria dual (aspirina + clopidogrel) no es tan efectiva como la anticoagulación oral para la prevención de accidente cerebrovascular en FA y aumenta significativamente el riesgo de sangrado. **d) Duplicaría la dosis de aspirina:** Aumentar la dosis de aspirina no mejora la eficacia en la prevención de accidentes cerebrovasculares cardioembólicos y solo incrementa el riesgo de hemorragia. La aspirina no es la terapia adecuada para este mecanismo de ictus. **e) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica:** Aunque restaurar el ritmo sinusal es deseable, la paciente ya ha fallado a la cardioversión previamente (eléctrica y farmacológica), y aún si se lograra, los pacientes con FA de alto riesgo y antecedentes de ACV/AIT a menudo requieren anticoagulación independientemente del ritmo debido al riesgo residual y las alteraciones estructurales (aurícula izquierda aumentada). La prioridad es la prevención de eventos isquémicos mediante anticoagulación efectiva.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes**

1.08.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la opción a) Alcohol y hepatitis C, ya que son las causas más prevalentes de daño hepático crónico en Chile y a nivel mundial, conduciendo a cirrosis y carcinoma hepatocelular. El consumo crónico y excesivo de alcohol es, sin lugar a dudas, una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en Chile. La hepatopatía alcohólica abarca un espectro de enfermedades que van desde la esteatosis hepática (hígado graso), pasando por la hepatitis alcohólica, hasta la cirrosis y sus complicaciones, como la insuficiencia hepática y el carcinoma hepatocelular. La alta prevalencia de consumo de alcohol en Chile contribuye significativamente a la carga de esta enfermedad. La infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) es la otra gran causa de daño hepático crónico. El VHC persiste en el hígado, causando inflamación y fibrosis progresiva que puede tardar décadas en manifestarse clínicamente, pero que invariablemente lleva a cirrosis en un porcentaje significativo de pacientes. Aunque la prevalencia de VHC en la población general chilena no es tan alta como en otras regiones del mundo, sigue siendo una causa muy relevante de enfermedad hepática avanzada, trasplantes hepáticos y mortalidad asociada a hepatopatía crónica. La co-ocurrencia de consumo de alcohol y hepatitis C acelera significativamente la progresión del daño hepático. Análisis de distractores: * **b) Alcohol y hepatitis B**: Si bien el alcohol es correcto, la hepatitis B crónica (VHB) tiene una prevalencia mucho menor en Chile en comparación con la hepatitis C. Chile es un país de baja endemicidad para VHB, y la vacunación universal ha reducido aún más su impacto, por lo que no figura entre las dos causas *más frecuentes* de daño hepático crónico en el país, a diferencia de otras regiones del mundo. * **c) Alcohol y tumoral**: El término "tumoral" es muy inespecífico. Si bien el carcinoma hepatocelular es una complicación grave del daño hepático crónico, no es la *causa inicial* del daño. El cáncer de hígado se desarrolla en un hígado previamente dañado por alcohol, hepatitis viral u otras etiologías. Por lo tanto, no es una causa primaria de daño hepático crónico en el mismo sentido que el alcohol o un virus. * **d) Alcohol y NASH**: La esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés) es, de hecho, una causa creciente e importante de daño hepático crónico, estrechamente relacionada con la obesidad, diabetes y síndrome metabólico, enfermedades cuya prevalencia está en aumento en Chile. Sin embargo, históricamente y hasta las estadísticas más recientes que suelen ser la base de estas preguntas, la combinación de alcohol y hepatitis C ha sido considerada la más frecuente. Aunque NASH está ganando terreno rápidamente y en el futuro podría superar a HCV en algunas poblaciones, al momento de la formulación de la pregunta, HCV mantenía su posición como una de las causas principales junto con el alcohol. * **e) Alcohol y autoinmune**: Las enfermedades hepáticas autoinmunes (como la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria) son causas importantes de daño hepático crónico, pero su prevalencia es significativamente menor que la del consumo de alcohol o la infección por hepatitis C. Son condiciones relativamente raras en comparación con las etiologías virales y metabólicas.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: D**

**Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes**

1.08.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

ntídoto para los Cumarínicos: El antídoto para los cumarínicos o antagonistas de la vitamina K varía según la urgencia para revertir su efecto. Reversión inmediata: Se debe administrar plasma fresco congelado. Reversión no urgente: Se debe administrar vitamina K.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: E**

**Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo**

1.08.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es una coagulación intravascular diseminada clásica.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: C**

**Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo**

1.08.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades. La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido. Análisis de distractores: a) Tiempo de protrombina (TP) e INR: El TP/INR evalúa la vía extrínseca de la coagulación y se utiliza principalmente para monitorizar la anticoagulación con warfarina (anticoagulantes orales). No es el examen de elección para monitorizar la HNF. b) Tiempo de trombina (TT): El TT evalúa directamente la conversión del fibrinógeno en fibrina por la trombina. Si bien la HNF afecta la actividad de la trombina, el TT es muy sensible a la presencia de heparina y no es útil para la monitorización rutinaria de la HNF. Se ve alterado incluso con dosis bajas de heparina, haciendo difícil la diferenciación de los niveles terapéuticos. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y no se utiliza para monitorizar la anticoagulación con heparina. e) No requiere control con exámenes: La anticoagulación con HNF requiere monitorización con exámenes de laboratorio debido a la variabilidad en la respuesta de los pacientes y el riesgo de complicaciones hemorrágicas si la anticoagulación no es adecuada.

---

## BLOQUE 4 ONCOHEMATOLOGÍA: NEOPLASIAS MIELOIDES Y LINFOIDES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A**

**Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**

1.08.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Era una leucemia aguda clásica.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

**Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**

1.08.1.009 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La respuesta correcta es Leucemia Mieloide Aguda (LMA). La presentación clínica del paciente con astenia, fiebre ocasional, esplenomegalia y palidez es sugerente de una patología hematológica maligna. El hemograma revela una anemia moderada (Hcto: 29%, Hb: 9,2 g/dl) y una leucocitosis marcada (blancos: 43.000). El diferencial de leucocitos es crucial para el diagnóstico: un 95% de neutrófilos con una presencia significativa de promielocitos (74%) es altamente anormal. Los promielocitos son células inmaduras de la línea mieloide, y su gran cantidad, junto con la presencia de blastos (6%), indica una proliferación descontrolada de células mieloides inmaduras. Los promielocitos descritos con citoplasma abundante, núcleos bilobulados/plegados y gránulos gruesos, son características morfológicas típicas de promielocitos patológicos en el contexto de una LMA, especialmente en subtipos como la LMA M3 (Leucemia Promielocítica Aguda), aunque la descripción es generalizable a otros tipos de LMA. La presencia de blastos, células embrionarias anómalas, es un criterio diagnóstico definitorio para la LMA. Análisis de distractores: a) Leucemia mieloide crónica (LMC): La LMC se caracteriza típicamente por una leucocitosis marcada con una diferenciación mieloide madura, incluyendo presencia de todas las etapas de maduración (basales, mielocitos, metacitos, formas maduras), y usualmente no presenta un alto porcentaje de blastos. La LMC clásica tampoco muestra la predominancia de promielocitos patológicos observada en este caso. c) Mononucleosis infecciosa: La mononucleosis infecciosa es una infección viral (generalmente por el virus de Epstein-Barr) que causa linfocitosis, a menudo con linfocitos atípicos, y típicamente no cursa con esplenomegalia significativa ni con la presencia de promielocitos o blastos. d) Fiebre tifoídea: La fiebre tifoídea es una infección bacteriana que típicamente causa fiebre alta, malestar general y puede cursar con leucopenia o leucocitosis leve, pero no se asocia con la presencia de promielocitos o blastos en sangre periférica. e) Mielodisplasia: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de neoplasias mieloides caracterizadas por hematopoyesis ineficaz y citopenias, con un riesgo de transformación a LMA. Si bien pueden haber displasias en las células mieloides y un aumento de blastos, el cuadro descrito con un 74% de promielocitos patológicos y 6% de blastos es mucho más compatible con una LMA establecida que con un SMD típico.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: C**

**Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**

1.08.1.009 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La alternativa correcta es la **C (Leucemia mieloide aguda.)**. La clave aquí es la presencia de un alto porcentaje de blastos (75%) en el hemograma. En general, se considera que un porcentaje de blastos ≥20% en sangre periférica o médula ósea es suficiente para el diagnóstico de leucemia aguda, según los criterios de la OMS. La leucemia mieloide aguda (LMA) se caracteriza por la proliferación clonal descontrolada de precursores mieloides (blastos) en la médula ósea, lo que interfiere con la hematopoyesis normal y conduce a citopenias. El paciente de 30 años presenta cansancio (sintomático de anemia) y el hemograma reporta leucocitos en rango normal (4.800/microL) pero con el porcentaje de blastos muy elevado. Esto sugiere fuertemente la presencia de una LMA. Si bien el recuento de leucocitos puede estar elevado, normal o disminuido en la LMA, el hallazgo de >20% de blastos es diagnóstico. **Referencia:** Si bien no existe una guía clínica MINSAL específica para leucemia mieloide aguda, las guías internacionales y textos de hematología son consistentes con este criterio diagnóstico. La OMS es la principal autoridad en la clasificación de neoplasias hematológicas. Análisis de distractores: * **A: Anemia refractaria con exceso de blastos:** Esta es una forma de síndrome mielodisplásico (SMD). Los SMD suelen presentarse con citopenias (anemia, trombocitopenia, leucopenia) y un porcentaje de blastos elevado, pero generalmente menor al 20% en sangre periférica y hasta 30% en médula ósea. Aunque un SMD puede transformarse en LMA, el porcentaje de blastos en este caso es mucho más alto que lo esperado para un SMD. * **B: Leucemia linfática crónica:** Esta es una leucemia crónica que afecta a linfocitos maduros. En la LLC, el recuento de linfocitos está elevado y los blastos no son la característica principal. Además, es mucho más común en personas mayores. * **D: Leucemia mieloide crónica en fase crónica:** La LMC se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia (t(9;22)) y la proteína de fusión BCR-ABL. En la fase crónica, el recuento de leucocitos está elevado, pero el porcentaje de blastos es bajo (<5%). * **E: Leucemia mielomonocítica crónica:** Esta es una neoplasia mieloproliferativa/mielodisplásica crónica caracterizada por un aumento de monocitos en sangre periférica y displasia en una o más líneas celulares mieloides. Si bien puede haber blastos elevados, no suelen ser tan altos como en este caso (>20%).

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: E**

**Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**

1.08.1.009 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Leucemias agudas.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: C**

**Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante**

1.08.1.009 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La clínica es de leucemia aguda. En la práctica es imposible diferenciar una leucemia mieloide aguda de una linfática aguda solo por la clínica, pero las adenopatías y la edad (joven) sugieren más una leucemia linfática aguda.

**PREGUNTA 60** **Respuesta: E**

**Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)**

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: C**

**Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)**

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC) es un trastorno clonal de la célula madre hematopoyética que se caracteriza por una proliferación excesiva de granulocitos y sus precursores inmaduros en la médula ósea y la sangre periférica. Se considera un síndrome mieloproliferativo clásico debido a su origen en las células mieloides y la tendencia a la proliferación descontrolada de estas líneas celulares. La LMC está fuertemente asociada con la presencia del cromosoma Filadelfia (Ph), resultado de una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 (t(9;22)(q34;q11)), que genera el gen de fusión BCR-ABL. Este gen codifica una proteína tirosina quinasa constitutivamente activa que impulsa la proliferación celular y la resistencia a la apoptosis. La LMC es un ejemplo prototípico de síndrome mieloproliferativo porque la alteración primaria reside en la médula ósea, afectando la producción de células mieloides. La proliferación desmedida de estas células conduce a un aumento significativo en el recuento de glóbulos blancos (leucocitosis), a menudo con un aumento de células inmaduras, así como a un aumento de plaquetas y, en ocasiones, de glóbulos rojos. A diferencia de otras neoplasias hematológicas, la LMC se caracteriza por una evolución generalmente indolente en su fase crónica, con progresión a fases acelerada y blástica si no se trata, lo que subraya su naturaleza mieloproliferativa. Análisis de distractores: a) Linfoma: El linfoma es un cáncer del sistema linfático, originado en los linfocitos, que son células del linaje linfoide. Los síndromes mieloproliferativos, por definición, afectan las células del linaje mieloide. b) Leucemia de células peludas: La leucemia de células peludas es una neoplasia linfoide rara, específicamente un tipo de leucemia de células B crónicas, y no un síndrome mieloproliferativo. d) Mielodisplasia: La mielodisplasia, o síndrome mielodisplásico, es un grupo de neoplasias mieloides en las que la médula ósea produce células sanguíneas anormales o inmaduras. A diferencia de los síndromes mieloproliferativos que se caracterizan por una proliferación descontrolada, en la mielodisplasia hay una ineficacia hematopoyética con citopenias y displasia (desarrollo anormal) de las células. e) Mieloptisis: La mieloptisis se refiere al reemplazo de la médula ósea normal por tejido fibroso, tumoral o granulomatoso, lo que lleva a una hematopoyesis ineficaz y a citopenias. Si bien puede ser secundaria a varias enfermedades, no es un síndrome mieloproliferativo primario.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: E**

**Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)**

1.08.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La leucemia mieloide crónica (LMC) se caracteriza clásicamente por la presencia del cromosoma Filadelfia (translocación t(9;22) que crea el gen de fusión BCR-ABL1), lo cual conduce a una tirosina quinasa constitutivamente activa. Este gen impulsa la proliferación descontrolada de células mieloides en la médula ósea, resultando en una leucocitosis (con predominio neutrofílico y desviación izquierda, indicando la presencia de precursores inmaduros), trombocitosis (aumento de plaquetas) y, en algunos casos, esplenomegalia. La presencia simultánea de estas tres alteraciones hematológicas apunta fuertemente a LMC, especialmente en ausencia de otras causas evidentes como infección severa. Si bien la médula ósea es la que otorga el diagnóstico definitivo, estos hallazgos periféricos son altamente sugestivos. Las guías clínicas del MINSAL para el manejo de leucemias resaltan la importancia de la sospecha diagnóstica temprana basada en hallazgos de laboratorio como estos para iniciar la evaluación y tratamiento oportuno. Análisis de distractores: * **A: Sepsis por bacterias Gram negativas:** La sepsis cursa con leucocitosis (o leucopenia en casos severos) y desviación izquierda, pero usualmente NO con trombocitosis. La trombocitopenia es más común en sepsis, especialmente si hay coagulación intravascular diseminada (CID). La etiología Gram negativa podría sugerirse con un shock séptico refractario a fluidos y vasopresores, sin embargo no es un hallazgo laboratorial directo. * **B: Reacción leucemoide:** Una reacción leucemoide es una elevación marcada de los leucocitos (generalmente >50.000/uL) con desviación izquierda, que puede simular una leucemia. Sin embargo, generalmente es causada por una infección severa, inflamación o estrés agudo. Si bien puede presentar trombocitosis, no es un hallazgo tan constante como en la LMC. Adicionalmente, una reacción leucemoide cesa una vez resuelta la causa subyacente, mientras que la LMC persiste y progresa sin tratamiento. * **C: Leucemia aguda promielocítica (LAP):** La LAP es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA) caracterizada por la acumulación de promielocitos en la médula ósea. Se asocia frecuentemente con CID y trombocitopenia, no trombocitosis. La leucocitosis puede estar presente, pero no es un rasgo definitorio y puede incluso haber leucopenia. * **D: Leucemia aguda mielocítica (LMA):** La LMA, en general, también se caracteriza por la presencia de blastos en sangre periférica y médula ósea. Si bien puede haber leucocitosis, es más común encontrar citopenias (anemia, trombocitopenia). La trombocitosis no es una característica típica de la LMA, exceptuando algunos subtipos raros.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)**

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Linfoma de Hodgkin: La historia clínica sugiere un linfoma, probablemente de Hodgkin, por la presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, malestar) y la edad. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia ganglionar.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

**Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)**

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La afirmación falsa sobre los linfomas de bajo grado es que la tasa de recaídas después del tratamiento con quimioterapia suele ser muy baja. Si bien los linfomas de bajo grado a menudo responden bien inicialmente a la quimioterapia, son notoriamente conocidos por tener una alta tasa de recaída. El tratamiento puede inducir remisiones prolongadas, pero la enfermedad suele reaparecer con el tiempo. La quimioterapia en este contexto se utiliza más para controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida que para lograr una cura definitiva. Las opciones de tratamiento a menudo se centran en la vigilancia activa ("watchful waiting") hasta que la enfermedad provoque síntomas que requieran intervención. La razón principal por la que la opción A es incorrecta radica en la biología de estos linfomas. Suelen ser indolentes y de crecimiento lento, pero son difíciles de erradicar por completo con los regímenes de quimioterapia estándar. Las células tumorales residuales, a menudo presentes en la médula ósea o en otros tejidos linfoides, pueden volver a proliferar con el tiempo, lo que lleva a la recaída. Análisis de distractores: * **b) Al momento del diagnóstico suelen estar diseminados:** Esta es una característica común de los linfomas de bajo grado. Debido a su crecimiento lento y la falta de síntomas iniciales, a menudo se detectan en etapas avanzadas (III o IV) con afectación de múltiples ganglios linfáticos o incluso la médula ósea. * **c) Suelen presentar sobrevidas sobre los 10 años:** En general, la sobrevida de los pacientes con linfomas de bajo grado suele ser prolongada, a menudo superando los 10 años, especialmente con el manejo moderno y las opciones de tratamiento disponibles. Sin embargo, es crucial recordar que la enfermedad es incurable en la mayoría de los casos. * **d) En los adultos mayores, suelen observarse:** La incidencia de los linfomas de bajo grado aumenta con la edad, por lo que es más común observarlos en adultos mayores. * **e) Se diagnostican mediante biopsias ganglionares:** El diagnóstico definitivo de un linfoma requiere una biopsia del ganglio linfático afectado. La histología y la inmunohistoquímica son esenciales para determinar el tipo específico de linfoma y su grado.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: D**

**Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)**

1.08.1.011

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La respuesta correcta es la (d) Translocaciones cromosómicas. Los linfomas, que son un grupo de cánceres que se originan en las células del sistema linfático (linfocitos), a menudo se caracterizan por la presencia de alteraciones genéticas específicas, siendo las translocaciones cromosómicas una de las más comunes y definitorias. Estas translocaciones implican el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, lo que puede dar lugar a la formación de genes de fusión oncogénicos o a la desregulación de genes clave en el crecimiento y la proliferación celular. Ejemplos clásicos incluyen la translocación t(8;14) en el linfoma de Burkitt, que une el gen MYC al promotor del gen de la inmunoglobulina, resultando en una sobreexpresión de MYC y una proliferación celular descontrolada. Estas alteraciones genéticas son fundamentales en la patogénesis de muchos tipos de linfoma, ya que pueden afectar vías de señalización celular importantes, interferir con la apoptosis (muerte celular programada) o promover la inestabilidad genómica. La identificación de translocaciones específicas es crucial para el diagnóstico, la clasificación y la elección del tratamiento en linfomas, ya que ciertas translocaciones están asociadas a pronósticos particulares y a la respuesta a terapias dirigidas. La naturaleza clonal de estas alteraciones subraya su papel en el origen maligno de estas neoplasias. Análisis de distractores: a) Mutaciones autosómicas dominantes: Si bien las mutaciones genéticas son importantes en el cáncer, los linfomas no se caracterizan predominantemente por mutaciones autosómicas dominantes como mecanismo principal de su origen. La mayoría de las mutaciones que conducen al cáncer son acumulativas y pueden afectar tanto a genes supresores de tumores como a oncogenes, y si bien algunas pueden ser dominantes, el patrón más distintivo en linfomas son las translocaciones. b) Mutaciones autosómicas recesivas: Las mutaciones recesivas generalmente requieren la inactivación de ambas copias de un gen para manifestar su efecto fenotípico. Si bien pueden ocurrir mutaciones recesivas en el desarrollo de linfomas, no son el tipo de alteración genética más definitoria o prevalente que impulse su iniciación y progresión. c) Mutaciones ligadas al sexo: Las mutaciones ligadas al sexo ocurren en los cromosomas sexuales (X o Y). Los linfomas afectan a ambos sexos, y aunque los cromosomas sexuales pueden ser el sitio de algunas alteraciones, la mayoría de las translocaciones o mutaciones significativas que impulsan el desarrollo de linfomas no están específicamente ligadas al sexo. e) Aneuploidías: Las aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas (por ejemplo, tener un cromosoma extra o faltar uno). Si bien las aneuploidías pueden estar presentes en algunos linfomas y contribuir a la inestabilidad genómica, no son el mecanismo genético primario que define el origen de la mayoría de los linfomas, a diferencia de las translocaciones cromosómicas que suelen ser eventos iniciadores y altamente característicos.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

**Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)**

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Era un mieloma múltiple, por cadenas ligeras peak monoclonal Kappa .

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: C**

**Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)**

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de un paciente de 65 años con dolores óseos, creatinina elevada (2.1 mg/dL), anemia (Hb: 9.7 g/dL) e hipercalcemia (11.1 mg/dL) es altamente sugestiva de Mieloma Múltiple. El Mieloma Múltiple es una neoplasia maligna de las células plasmáticas, caracterizada por la proliferación monoclonal de estas células en la médula ósea. La infiltración de la médula ósea por células plasmáticas anómalas puede desplazar a las células hematopoyéticas normales, llevando a anemia. Las lesiones líticas óseas, que causan los dolores óseos, son una manifestación clásica y son responsables de la liberación de calcio a la sangre, provocando hipercalcemia. Además, la disfunción renal observada en la creatinina elevada puede ser secundaria a la nefrotoxicidad por cadenas ligeras de inmunoglobulinas (proteinuria de Bence Jones), hipercalcemia severa o amiloidosis asociada. Análisis de distractores: a) Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado: Si bien el paciente presenta insuficiencia renal y potencial hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal (que podría explicar la hipercalcemia), el dolor óseo difuso y la anemia marcada en este contexto son menos típicos de una IRC sin otra causa subyacente. La combinación de estos tres hallazgos es más específica de otra patología. b) Anemia de enfermedades crónicas: La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza por ser normocítica, normocrómica y típicamente leve a moderada. Si bien puede coexistir con otras condiciones, no explica por sí sola la presencia de dolores óseos y una marcada hipercalcemia. d) Déficit de proteína C: El déficit de proteína C es un trastorno de la coagulación que predispone a eventos trombóticos, no a dolores óseos, anemia o hipercalcemia. e) Cáncer de próstata: El cáncer de próstata, especialmente en etapas avanzadas, puede metastatizar a hueso causando dolor y elevación de la fosfatasa alcalina. Sin embargo, la hipercalcemia y la anemia marcadas no son hallazgos tan prominentes ni característicos como en el Mieloma Múltiple, y la disfunción renal tampoco es una manifestación primaria típica, a menos que haya obstrucción o compromiso metastásico extenso.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: A**

**Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)**

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la **a) Observar evolución**. El caso describe un Gamapatía Monoclonal de Significado Incierto (MGUS). MGUS se define por la presencia de una proteína monoclonal (proteína M) en suero u orina, menos del 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea y ausencia de daño orgánico asociado (CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas) atribuible al trastorno de células plasmáticas. Dado que el paciente cumple con estos criterios y no presenta síntomas ni evidencia de mieloma múltiple o amiloidosis de cadenas ligeras relacionada, la conducta inicial apropiada es la observación periódica para detectar una posible progresión a mieloma múltiple u otra gamapatía maligna. El seguimiento generalmente implica la repetición de la electroforesis de proteínas y la evaluación de calcio, función renal, hemograma, y en ocasiones, biopsia de médula ósea, a intervalos regulares, dependiendo del riesgo de progresión. Análisis de distractores: b) **Indicar quimioterapia:** La quimioterapia no está indicada en MGUS, ya que no hay evidencia de mieloma múltiple activo u otra gamapatía maligna que requiera tratamiento. La quimioterapia se reserva para pacientes con mieloma múltiple sintomático o gamapatías relacionadas. c) **Iniciar ácido acetil salicílico:** El ácido acetil salicílico (aspirina) no tiene un papel en el tratamiento de MGUS. d) **Iniciar hidroxiurea:** La hidroxiurea se utiliza en algunos trastornos mieloproliferativos, pero no es un tratamiento para MGUS. e) **Realizar trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea es una opción de tratamiento para mieloma múltiple, pero no para MGUS, que es una condición premaligna asintomática.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

**Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)**

1.08.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Anemia, insuficiencia renal, dolores óseos. Es un mieloma.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: E**

**Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia**

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una mielofibrosis clásica, sin embargo, toda mielofibrosis es a su vez una mielop- tisis. No debería haber un distractor correcto.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: C**

**Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia**

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro clínico presentado, con un hematocrito elevado (62%), hemoglobina alta (20.6 g/dl), plaquetas aumentadas (500,000 por mm3), y la presencia de esplenomegalia, es altamente sugestivo de Policitemia Vera. La Policitemia Vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por la proliferación clonal de precursores eritroides, pero que también afecta a las líneas granulocítica y megacariocítica, lo que explica el aumento en las plaquetas. La esplenomegalia es un hallazgo común debido a la extramedularidad de la hematopoyesis. El diagnóstico diferencial en un paciente con policitemia (aumento de glóbulos rojos) debe considerar causas primarias y secundarias. La Policitemia Vera se considera una causa primaria. En este caso, la combinación de policitemia, trombocitosis y esplenomegalia en un paciente sin otra patología aparente apunta fuertemente hacia esta condición, siendo la mutación JAK2 la más frecuente y un marcador diagnóstico clave. Análisis de distractores: a) Hemograma normal: Es incorrecto porque los valores de hematocrito y hemoglobina están significativamente elevados, indicando policitemia. b) Anemia por enfermedades crónicas: Es incorrecto, ya que esta condición se caracteriza por anemia (disminución de glóbulos rojos), no policitemia. d) Trombocitosis esencial: Es incorrecta. Si bien hay trombocitosis, la Trombocitosis Esencial se caracteriza principalmente por un aumento aislado de plaquetas, sin policitemia significativa ni esplenomegalia marcada como hallazgos centrales. e) Poliglobulia por hipoxemia: Es incorrecta. Si bien la hipoxemia puede causar policitemia secundaria (debido a un estímulo compensatorio por eritropoyetina), generalmente no se acompaña de trombocitosis ni esplenomegalia de esta magnitud, y suele haber una causa subyacente de hipoxemia (enfermedad pulmonar, cardíaca, etc.) que no se menciona en el caso.

**PREGUNTA 72** **Respuesta: C**

**Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia**

1.08.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En un paciente con policitemia vera de bajo riesgo, el objetivo principal del tratamiento es reducir la masa de glóbulos rojos para prevenir complicaciones trombóticas, que son el principal riesgo asociado a esta enfermedad. La sangría terapéutica, también conocida como flebotomía, es el método más directo y efectivo para disminuir rápidamente el hematocrito y la viscosidad sanguínea. La aspirina se administra de forma concomitante para reducir aún más el riesgo de eventos trombóticos, ya que la policitemia vera se asocia con un estado de hipercoagulabilidad. El enfoque en pacientes de bajo riesgo se centra en el control sintomático y la prevención de complicaciones a través de medidas más conservadoras y menos agresivas que en casos de alto riesgo. Análisis de distractores: a) Eritropoyetina subcutánea y aspirina: La eritropoyetina es un estimulador de la producción de glóbulos rojos, por lo que estaría contraindicada en un paciente con poliglobulia. Su uso podría empeorar la condición. b) Quimioterapia combinada y aspirina: La quimioterapia, como la hidroxiurea, se reserva para pacientes con policitemia vera de alto riesgo, quienes tienen un riesgo significativo de transformación a leucemia mieloide aguda o mielofibrosis, o presentan síntomas severos. En pacientes de bajo riesgo, es un tratamiento excesivo y conlleva riesgos de toxicidad innecesarios. d) Anticoagulación oral a permanencia: La anticoagulación oral no es el tratamiento de elección para la policitemia vera. Si bien el riesgo trombótico es elevado, la causa subyacente es la producción excesiva de glóbulos rojos, y la anticoagulación no aborda esta patología primaria. Además, podría aumentar el riesgo de hemorragias. e) Trasplante de médula ósea: El trasplante de médula ósea es un tratamiento curativo pero altamente agresivo, reservado para pacientes de alto riesgo con policitemia vera que no responden a otros tratamientos o que presentan transformación maligna. No es apropiado para un paciente de bajo riesgo.

## BLOQUE 5 URGENCIAS ONCOHEMATOLÓGICAS, TROMBOFILIAS Y MEDICINA TRANSFUSIONAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C**

**Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica**

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 7). Evalúa el manejo clínico de Neutropenia febril según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A**

**Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica**

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presentación clínica del paciente, un niño de 5 años con exantema petequial y sangrado gingival después de una infección respiratoria reciente, sugiere fuertemente una trombocitopenia inmune (PTI) aguda. La PTI es una causa común de trombocitopenia en niños, a menudo precedida por una infección viral. Las petequias, el sangrado gingival y la ausencia de otros síntomas sistémicos apuntan a un problema primario con las plaquetas. El examen inicial y más importante es determinar si el paciente tiene trombocitopenia, lo que se logra mediante un hemograma con recuento de plaquetas. Un hemograma con recuento de plaquetas confirmará la presencia de trombocitopenia (recuento de plaquetas bajo). Una vez confirmada la trombocitopenia, se pueden considerar otras pruebas para descartar otras causas o evaluar la gravedad de la condición, pero el hemograma es el primer paso esencial para confirmar la sospecha diagnóstica. El contexto clínico apunta claramente a una etiología inmune post-infecciosa, por lo que la evaluación inicial debe enfocarse en confirmar la trombocitopenia. Análisis de distractores: b) Hemocultivos: Los hemocultivos se utilizan para detectar bacterias en la sangre, lo cual es relevante en casos de sepsis o infecciones sistémicas graves. En este caso, el paciente se encuentra afebril y en buenas condiciones generales, sin signos de infección activa grave que justifiquen la realización de hemocultivos. Si bien una infección pasada podría ser un factor desencadenante, la prueba directa no está indicada en este momento. c) Pruebas de agregación plaquetaria: Las pruebas de agregación plaquetaria evalúan la función de las plaquetas, pero son más útiles para investigar trastornos plaquetarios hereditarios o adquiridos que afectan la función plaquetaria, como la enfermedad de von Willebrand o el uso de antiagregantes plaquetarios. En este caso, la sospecha es de PTI, donde el problema principal es la disminución del número de plaquetas, no su función. d) Tiempo de sangría: El tiempo de sangría evalúa la función plaquetaria y la capacidad de formar un coágulo inicial. Aunque puede estar prolongado en la trombocitopenia, no es el examen inicial de elección para confirmar la sospecha diagnóstica, ya que es menos preciso y más invasivo que un simple recuento de plaquetas. Además, un tiempo de sangría prolongado podría deberse a otras causas aparte de la trombocitopenia. e) Tiempos de protrombina y de tromboplastina parcial activada (TP/TTPa): TP y TTPa evalúan las vías de coagulación intrínseca y extrínseca, respectivamente. Están indicados en la evaluación de trastornos de la coagulación, como deficiencias de factores de coagulación o anticoagulantes. En este caso, la presentación clínica sugiere un problema plaquetario (PTI) y no un trastorno de la coagulación. Los tiempos de coagulación suelen ser normales en la PTI.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: E**

**Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica**

1.08.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un escenario clínico común en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia: neutropenia febril. La neutropenia, una disminución significativa de neutrófilos en la sangre, compromete gravemente la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones bacterianas. La fiebre en este contexto es una señal de alarma que requiere intervención inmediata y empírica. *Pseudomonas aeruginosa* es un patógeno oportunista de alta virulencia y frecuentemente implicado en infecciones graves en pacientes neutropénicos, incluso en ausencia de un foco infeccioso aparente. Por lo tanto, el tratamiento empírico debe asegurar una cobertura antibiótica potente y de amplio espectro contra este bacilo gramnegativo. La combinación de Ceftazidina (una cefalosporina de tercera generación con excelente actividad contra *Pseudomonas aeruginosa*) y Amikacina (un aminoglucósido que también tiene una buena cobertura contra *Pseudomonas* y sinergia potencial con las cefalosporinas) proporciona una doble cobertura adecuada para abordar las infecciones bacterianas más probables y graves en este tipo de pacientes. Esta combinación ha sido históricamente recomendada y sigue siendo una opción sólida para el manejo empírico de la neutropenia febril, especialmente cuando se sospecha o se desea cubrir patógenos como *Pseudomonas*. Análisis de distractores: a) Ceftriaxona + gentamicina: Si bien la ceftriaxona es un antibiótico eficaz, su cobertura contra *Pseudomonas aeruginosa* no es tan robusta como la de la ceftazidima. La gentamicina es un aminoglucósido, pero la combinación de ceftriaxona con gentamicina puede ser insuficiente para garantizar una cobertura óptima contra *Pseudomonas* resistente o en situaciones de alta carga bacteriana. b) Piperacilina + vancomicina: La piperacilina es una penicilina antipseudomónica, lo cual es positivo. Sin embargo, la vancomicina está indicada principalmente para cubrir patógenos grampositivos, especialmente *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) y *Enterococcus* resistentes a la vancomicina (ERV). Si bien puede ser necesaria en casos seleccionados de neutropenia febril (por ejemplo, si hay sospecha de catéter infectado o colonización por SARM), no aborda de manera directa la alta probabilidad de infecciones por bacilos gramnegativos como *Pseudomonas*. c) Ciprofloxacino + metronidazol: El ciprofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad contra *Pseudomonas*. Sin embargo, el metronidazol está diseñado para cubrir anaerobios y algunas bacterias atípicas. En el manejo empírico inicial de la neutropenia febril, no es el agente más adecuado para complementar la cobertura contra *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos de importancia clínica. d) Levofloxacino + clindamicina: El levofloxacino es una fluoroquinolona con buena actividad antipseudomónica. Sin embargo, la clindamicina es un antibiótico que cubre grampositivos y anaerobios, pero su espectro no incluye a *Pseudomonas aeruginosa*. Esta combinación, aunque cubre algunos patógenos relevantes, no ofrece la doble cobertura específica y potente contra *Pseudomonas* requerida en este escenario.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: B**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: E**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es un síndrome de lisis tumoral clásico, con rotura celular masiva, que se refleja en hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfemia, hipocalcemia, acidosis, falla renal, compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico. Se trata con hidratación, hipouricemiantes (ej. alopurinol) y manejo de los electrolitos según las alteraciones (ej. Bicarbonato, calcio, furosemida, insulina más glucosa, resinas de intercambio como el sulfonato de poliestireno, etc.).

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: C**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la C) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención. El tratamiento estándar de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adultos y niños se basa en un régimen de quimioterapia intensiva que consta de varias fases. La fase de inducción tiene como objetivo lograr la remisión completa, es decir, erradicar la mayor cantidad posible de células leucémicas de la médula ósea. Posteriormente, la fase de consolidación (o intensificación) busca eliminar cualquier célula leucémica residual. Finalmente, la fase de mantenimiento, que puede durar varios años, se administra para prevenir la recaída de la enfermedad. Esta última fase es crucial para mantener la remisión a largo plazo, ya que la LLA tiene una alta tasa de recidiva si no se mantiene el tratamiento adecuado. La quimioterapia de inducción típicamente involucra una combinación de fármacos como vincristina, daunorrubicina (o doxorrubicina), asparaginasa y prednisona (o dexametasona). El tratamiento de mantenimiento generalmente incluye metotrexato y 6-mercaptopurina, administrados durante un período prolongado, junto con pulsos periódicos de otros fármacos. Este enfoque escalonado y combinado ha demostrado ser muy eficaz para mejorar las tasas de supervivencia en pacientes con LLA. La respuesta individual a la quimioterapia, la presencia de factores pronósticos adversos y la edad del paciente pueden influir en la elección de los fármacos específicos y la duración de cada fase del tratamiento. Análisis de distractores: * **A) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos:** La radioterapia a los huesos esponjosos no es una parte estándar del tratamiento de primera línea para la LLA, aunque puede utilizarse en casos específicos, como la afectación del sistema nervioso central (SNC) o la prevención de la recaída en el SNC. En la mayoría de los casos, la quimioterapia intratecal (administrada directamente en el líquido cefalorraquídeo) es preferible para tratar o prevenir la afectación del SNC. * **B) Trasplante de médula ósea:** El trasplante de médula ósea (o trasplante de células madre hematopoyéticas) no es el tratamiento de primera línea para todos los pacientes con LLA. Generalmente, se reserva para pacientes con enfermedad de alto riesgo o aquellos que recaen después de la quimioterapia inicial. El trasplante conlleva riesgos significativos y se realiza en centros especializados. * **D) Quimioterapia combinada de inducción sola:** Si bien la quimioterapia de inducción es esencial para lograr la remisión, no es suficiente por sí sola para tratar la LLA. Sin las fases de consolidación y mantenimiento, la probabilidad de recaída es muy alta. * **E) Exanguíneotransfusión y radioterapia:** La exanguíneotransfusión se utiliza principalmente en recién nacidos con problemas de incompatibilidad sanguínea o hiperbilirrubinemia grave, y no tiene un papel en el tratamiento de la LLA. La radioterapia, como se mencionó anteriormente, no es un componente estándar del tratamiento de primera línea.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La leucemia linfática aguda (LLA) en la infancia ha experimentado avances terapéuticos extraordinarios en las últimas décadas. Gracias a regímenes de quimioterapia intensificados, terapias dirigidas y un mejor manejo de las complicaciones, el pronóstico de supervivencia ha mejorado drásticamente. Actualmente, la tasa de supervivencia a 5 años para la LLA infantil se sitúa consistentemente por encima del 85%, y en algunos subgrupos de bajo riesgo, puede alcanzar incluso el 90% o más. Esta cifra representa un logro médico monumental, transformando la LLA de una enfermedad casi universalmente fatal a una patología con altas tasas de curación. Esta notable mejora se atribuye a una combinación de factores. La estratificación de riesgos basada en características clínicas y moleculares (como la citogenética y la presencia de marcadores específicos) permite adaptar los tratamientos a la agresividad individual de la enfermedad. Además, los protocolos de quimioterapia han evolucionado para ser más efectivos y, a su vez, se ha perfeccionado el soporte de soporte para manejar los efectos secundarios de estos tratamientos, como las infecciones y las toxicidades hematológicas. Análisis de distractores: b) 60%: Este porcentaje, aunque representa una mejora significativa sobre décadas pasadas, no refleja las tasas de supervivencia actuales. Estaría más acorde con el pronóstico de la LLA infantil en las décadas de 1970 o 1980, antes de los grandes avances terapéuticos. c) 30%: Esta tasa de supervivencia es demasiado baja para la LLA infantil actual y se asemeja más al pronóstico de otras leucemias o de la LLA en adultos sin tratamientos avanzados. d) 10%: Este porcentaje sería un pronóstico extremadamente sombrío, más propio de leucemias no tratadas o con complicaciones muy severas en épocas donde los tratamientos eran prácticamente inexistentes. e) 2%: Este valor es irrisorio y no representa en absoluto el pronóstico de la LLA infantil en la actualidad. Sería una tasa de mortalidad prácticamente del 100%.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Post quimioterapia: hiperuricemia + hiperkalemia + hiperfosfatemia + hipocalcemia + IRA = síndrome de lisis tumoral. Ocurre por destrucción masiva de células tumorales que liberan su contenido.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: E**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular**

1.08.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome de compresión medular" como urgencia clínica (1.08.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: C**

**Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo**

1.08.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una trombofilia (A y C son compatibles). El TTPA alargado y el VDRL reactivo orientan mucho a un síndrome antifosfolípidos. El déficit de facor VIII produce hemofilia, por lo que tiene hemorragias, al igual que la EvW.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo**

1.08.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La deficiencia de antitrombina III (ATIII) es la trombofilia congénita más severa debido a que la ATIII es un inhibidor clave en la cascada de coagulación. Actúa inhibiendo la trombina y otros factores de la coagulación como el factor Xa. Su deficiencia, ya sea cuantitativa (tipo I) o cualitativa (tipo II), produce un estado de hipercoagulabilidad significativa y un alto riesgo de trombosis venosa y arterial, incluyendo trombosis a edades tempranas y en sitios inusuales. La ATIII tiene un rol crucial en la regulación de la coagulación, y su ausencia o mal funcionamiento deja la cascada sin un freno importante, llevando a una producción excesiva de trombina y formación de coágulos. La severidad de la deficiencia de ATIII radica en que, a diferencia de otras trombofilias, la ATIII inhibe múltiples factores de la coagulación, no solo uno específico. Las otras trombofilias, como la resistencia a la proteína C activada por el factor V de Leiden o las deficiencias de proteína C y S, afectan mecanismos reguladores más específicos. Aunque estas también incrementan el riesgo trombótico, el impacto global en la coagulación es menor comparado con la deficiencia de ATIII. La hiperhomocisteinemia, aunque relacionada con un mayor riesgo cardiovascular y trombótico, se considera una trombofilia menos severa y a menudo está asociada a otros factores de riesgo modificables. Análisis de distractores: a) **Factor V de Leiden:** Causa resistencia a la proteína C activada, lo que incrementa el riesgo de trombosis. Sin embargo, su impacto es menor que la deficiencia de ATIII, ya que afecta un solo punto de regulación. Muchos individuos con Factor V de Leiden son asintomáticos o desarrollan trombosis en circunstancias específicas. c) **Déficit de proteína C:** La proteína C es un anticoagulante natural que inactiva los factores V y VIII activados. Su deficiencia aumenta el riesgo de trombosis, pero no al nivel de la deficiencia de ATIII, ya que la ATIII inhibe una gama más amplia de factores de la coagulación. d) **Déficit de proteína S:** La proteína S actúa como cofactor de la proteína C, potenciando su acción anticoagulante. Su deficiencia, similar al déficit de proteína C, aumenta el riesgo de trombosis, pero es menos severa que la deficiencia de ATIII debido al alcance más limitado de su acción. e) **Hiperhomocisteinemia:** La hiperhomocisteinemia se asocia con un riesgo incrementado de trombosis, pero es menos severa que las deficiencias de los anticoagulantes naturales. Además, la hiperhomocisteinemia puede ser influenciada por factores nutricionales y, en algunos casos, puede ser tratada con suplementos vitamínicos.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo**

1.08.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF. Análisis de distractores: * **a) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA):** ANA es relevante, pero el Factor Reumatoide se asocia principalmente con la Artritis Reumatoide, una condición que no explica tan bien la historia de abortos recurrentes y trombosis. * **c) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme:** El Factor Reumatoide no es el marcador principal aquí. No hay elementos clínicos que sugieran la enfermedad de Lyme (e.g., exposición a garrapatas, eritema migratorio). * **d) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA):** Si bien estos son anticuerpos específicos de LES (anti-ADN nativo es muy específico y anti-Ro se asocia a subtipos específicos de LES y Sjögren), son pruebas de confirmación. El ANA es una mejor prueba de *tamizaje inicial* y, fundamentalmente, esta opción omite la búsqueda de anticuerpos para el Síndrome Antifosfolípido (anticardiolipina), que es crucial dada la clínica. * **e) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas:** Los ANCAs son marcadores de vasculitis, que no es la presentación predominante aquí. Los anticuerpos antihistonas se asocian principalmente con el lupus inducido por fármacos, para lo cual no hay datos en la anamnesis.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: C**

**Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo**

1.08.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es otro síndrome antifosfolípidos, por la misma razón del TTPA alargado (mayor a 40).

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas**

1.08.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Reacción leucemoide" (1.08.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: C**

**Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas**

1.08.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Un paciente con grupo sanguíneo AB posee antígenos A y B en la superficie de sus glóbulos rojos y no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma. Por lo tanto, puede recibir glóbulos rojos de cualquier grupo sanguíneo (A, B, AB u O) sin riesgo de una reacción hemolítica por incompatibilidad ABO clásica. Recibir sangre de un grupo diferente al suyo no provocará que sus anticuerpos ataquen a los glóbulos rojos transfundidos, ya que no tiene tales anticuerpos. El grupo O, al carecer de antígenos A y B, no será atacado por ningún anticuerpo anti-A o anti-B. Los grupos A y B, al poseer el antígeno correspondiente, tampoco serán atacados ya que el paciente AB no posee anticuerpos anti-A ni anti-B. Finalmente, el grupo AB es compatible por definición. Por lo tanto, un paciente AB es considerado el "receptor universal" en el sistema ABO. Análisis de distractores: * **a) Sólo AB:** Esta opción es incorrecta porque el paciente AB puede recibir otros grupos sanguíneos además del AB, debido a la ausencia de anticuerpos anti-A y anti-B. * **b) AB, A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye el grupo O, el cual también es compatible debido a que carece de antígenos A y B, siendo seguro para cualquier grupo sanguíneo. * **d) O y AB:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos A y B, que también son compatibles con el grupo AB. * **e) A y B:** Esta opción es incorrecta porque no incluye los grupos O y AB, que también son compatibles con el grupo AB.

---

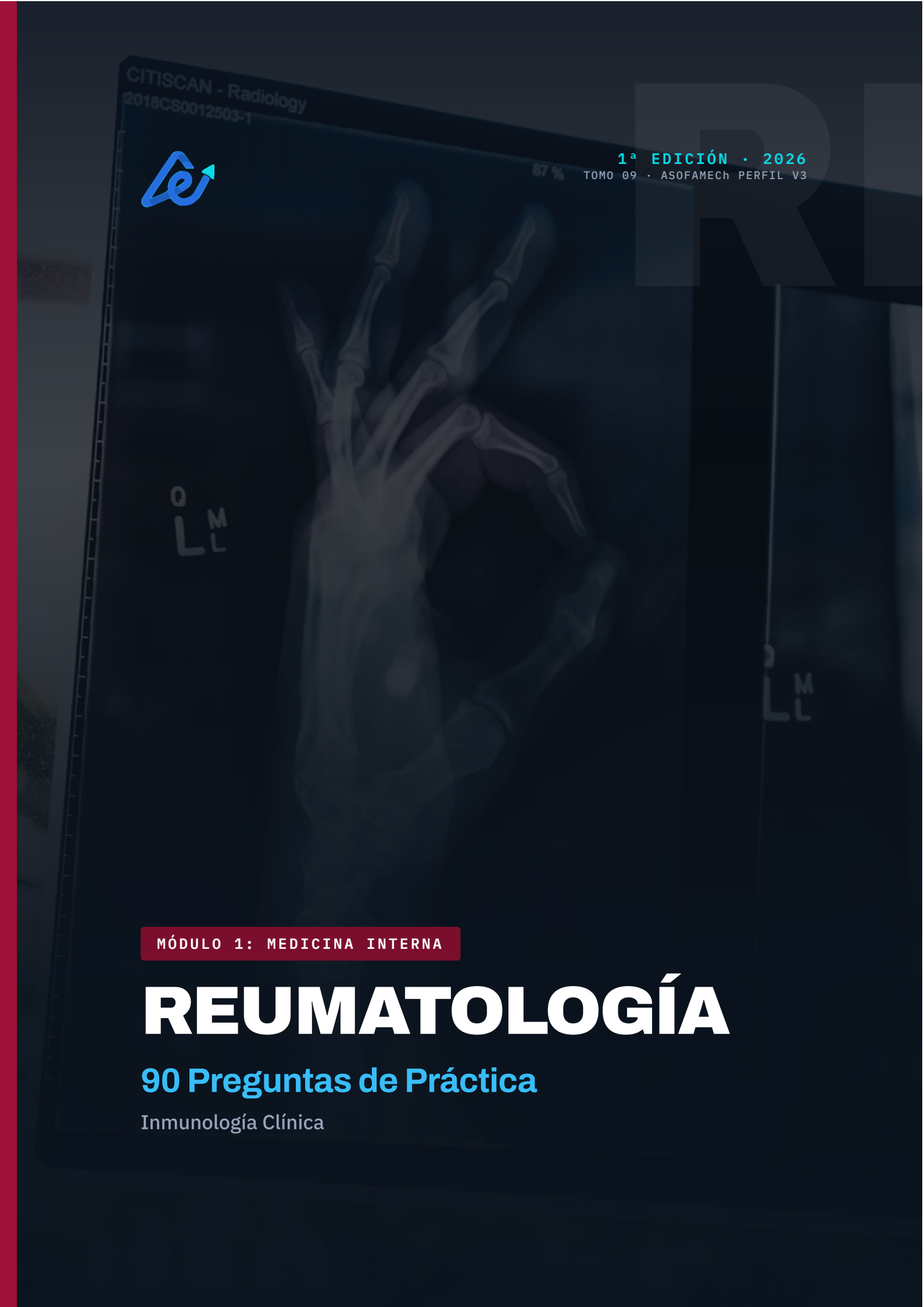
**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas**

1.08.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La reacción hemolítica transfusional en este caso es altamente probable y severa debido a la incompatibilidad ABO. Una persona con grupo sanguíneo A tiene antígeno A en sus glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en su plasma. Al recibir glóbulos rojos AB, el receptor A reconocerá el antígeno B presente en los glóbulos rojos transfundidos como extraño. Esto desencadenará una respuesta inmune inmediata, donde los anticuerpos anti-B del receptor se unirán a los glóbulos rojos AB donados, causando su aglutinación y posterior hemólisis intravascular. La hemólisis masiva libera hemoglobina en el torrente sanguíneo, lo que puede resultar en complicaciones graves como insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada (CID), shock e incluso la muerte. La gravedad y rapidez de la reacción son características de la incompatibilidad ABO, por lo que la probabilidad de una reacción hemolítica transfusional significativa es extremadamente alta, cercana o superior al 95%. Análisis de distractores: * **b) 65%-95%:** Aunque una reacción es muy probable, esta opción subestima la virtual certeza de la misma dada la incompatibilidad ABO completa. La respuesta inmune es predecible y rápida. * **c) 35%-65%:** Esta probabilidad es demasiado baja considerando la incompatibilidad ABO. Las reacciones hemolíticas transfusionales debidas a incompatibilidad ABO son casi siempre severas. * **d) 5%-35%:** Esta probabilidad es mucho menor a la que se esperaría. Este rango podría aplicar a incompatibilidades menores del sistema Rh u otros antígenos, pero no para ABO. * **e) Menor al 5%:** Esta probabilidad es extremadamente improbable. La incompatibilidad ABO resulta en una reacción hemolítica masiva en la gran mayoría de los casos.

---




1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 09 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# REUMATOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Inmunología Clínica

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Reumatología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR** | | | | | |
| 1.04.2.007 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q9, Q10, Q11, Q12 | Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.1.001 | Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q14, Q15, Q16 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.11.1.002 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17) |
| 1.11.1.003 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.004 | Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.007 | Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.015 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.016 | Oligoartritis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.019 | Poliartritis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.2.001 | Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q13 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.2.002 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO** | | | | | |
| 1.05.1.001 | Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q19, Q28, Q29, Q30, Q31, Q33, Q34, Q35, Q36 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.002 | Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q20, Q21, Q22, Q23 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.10.1.001 | Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 1.11.1.014 | Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES** | | | | | |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.006 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.05.1.004 | Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44, Q45, Q46, Q47 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.1.012 | Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q53 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.11.1.009 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.020 | Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48, Q49, Q50, Q51, Q52 | Tomo 09 · 9.13 (Pág. 51) |
| 1.11.1.021 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.022 | Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.023 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET** | | | | | |
| 1.04.1.010 | Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69, Q70 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.05.1.001 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q55, Q56 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.015 | Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71, Q72 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.08.1.002 | Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7) |
| 1.11.1.001 | Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65, Q66, Q67, Q68 | Tomo 09 · 9.18 (Pág. 68) |
| 1.11.1.006 | Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 13 · 13.13 (Pág. 48) |
| 1.11.1.012 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.013 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q58 | Tomo 09 · C.35 (Pág. 74) |
| 1.11.1.018 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO** | | | | | |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.008 | Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.012 | Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.014 | Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.11.1.005 | Cervicalgia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.008 | Epicondilalgia, epitroclealgias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.010 | Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.011 | Hombro doloroso | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.017 | Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q90 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.024 | Tendonitis y bursitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.025 | Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q81 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Reumatología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

**TOMO 09 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO**

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.006 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q37, Q38, Q39, Q40 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.04.1.010 | Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69, Q70 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.04.2.007 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q9, Q10, Q11, Q12 | Tomo 02 · 1.1 (Pág. 5) |
| 1.05.1.001 | Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q14, Q15, Q16, Q19, Q28, Q29, Q30, Q31, Q33, Q34, Q35, Q36, Q55, Q56 | Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30) |
| 1.05.1.002 | Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q20, Q21, Q22, Q23 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.05.1.004 | Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q44, Q45, Q46, Q47 | Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66) |
| 1.05.1.012 | Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q53 | Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41) |
| 1.05.1.015 | Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71, Q72 | Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62) |
| 1.08.1.002 | Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7) |
| 1.09.1.008 | Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 09 · 9.21 (Pág. 77) |
| 1.09.1.009 | Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69) |
| 1.09.1.012 | Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87 | Tomo 09 · 9.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.014 | Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89 | Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63) |
| 1.10.1.001 | Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 1.11.1.001 | Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65, Q66, Q67, Q68 | Tomo 09 · 9.18 (Pág. 68) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.1.002 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17) |
| 1.11.1.003 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.004 | Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.005 | Cervicalgia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.006 | Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 13 · 13.13 (Pág. 48) |
| 1.11.1.007 | Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.008 | Epicondilalgia, epitroclealgias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.009 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q41 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.010 | Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.011 | Hombro doloroso | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.012 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.013 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q58 | Tomo 09 · C.35 (Pág. 74) |
| 1.11.1.014 | Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.015 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.016 | Oligoartritis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.017 | Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q90 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.018 | Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.019 | Poliartritis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.020 | Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48, Q49, Q50, Q51, Q52 | Tomo 09 · 9.13 (Pág. 51) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto | | | | |
| 1.11.1.021 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.022 | Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.023 | Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.024 | Tendonitis y bursitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.1.025 | Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q81 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.2.001 | Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q13 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |
| 1.11.2.002 | Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR

PREGUNTA 1 1.11.1.016

**1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Oligoartritis · 1.11.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Oligoartritis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 1.11.1.019

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Poliartritis · 1.11.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Poliartritis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 1.04.2.007

**3. Un paciente de 70 años consulta por dolor muy intenso en la rodilla izquierda, asociada a aumento de volumen, calor local y eritema. Al examen físico presenta derrame articular y signos inflamatorios en dicha articulación. Se realiza una radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación a nivel del cartílago articular. La artrocentesis da salida a un líquido turbio, de filancia disminuida, con cerca de 10.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía en el microscopio de campo oscuro observa múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva. La 3/endocrinologiadiabetologiay-nutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/ 1/7 tinción de Gram no muestra bacterias. La conducta más adecuada es:**

A) Enviar a domicilio con paracetamol oral y una dieta pobre en calcio

B) Iniciar AINEs y alopurinol oral

C) Solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico, calcemia y paratohormona y decidir manejo según resultados

D) Iniciar AINEs endovenosos y reposo

E) Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje articular

PREGUNTA 4 1.04.2.007

**4. Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo es:**

A) AINEs y reposo

B) AINEs, bifosfonatos y reposo

C) AINEs, antibióticos, bifosfonatos y reposo

D) AINEs, diuréticos y reposo

E) AINEs, alopurinol y reposo

PREGUNTA 5 1.11.1.002

**5. Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:**

A) Artritis por cristales

B) Artritis por stafilococo aureus

C) Artritis por neisseria gonorrhoeae

D) Artritis reactiva

E) Artritis reumatoídea juvenil

PREGUNTA 6 1.11.1.003

**6. Paciente con dolor articular en MCF e IFP, con rigidez matinal importante. ¿Cuál es el examen específico a solicitar?**

A) Factor reumatoide (IgM)
B) ANA y anti-DNA doble cadena
C) Ácido úrico sérico
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA-B27

PREGUNTA 7 1.11.1.015

**7. Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar antibióticos endovenosos
B) Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico
C) Iniciar AINEs
D) Realizar artrocentesis diagnóstica
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

PREGUNTA 8 1.11.2.002

**8. Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controlar uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender el tratamiento
B) Aumetar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
C) Agregar probenecid al tratamiento
D) Suspender la colchicina
E) Agregar prednisona en baja dosis

PREGUNTA 9 1.04.2.007

**9. En un adolescente con síntomas de artritis séptica del tobillo derecho se realiza estudio de líquido sinovial que muestra un aspecto turbio, poco filante, con células 85.000 x mm3, con 95% de polimorfonucleares y visualización de abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:**

A) Administrar penicilina benzatina
B) Iniciar flucloxacilina oral
C) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
D) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje quirúrgico

PREGUNTA 10 1.04.2.007

**10. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en la artritis séptica de rodilla, con presencia de cocaceas Gram (-) intracelulares y cultivo negativo del líquido articular?**

A) Anaerobios
B) Chlamydia trachomatis
C) Neisseria gonorrhoeae
D) Streptococcus agalactiae
E) Staphylococcus aureus

PREGUNTA 11 1.04.2.007

**11. Un paciente de 33 años es diagnosticado de artritis séptica de cadera izquierda por estudio de líquido sinovial, con visualización de cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar cloxacilina oral e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
B) Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar uso de muletas, prohibiendo el apoyo de la extremidad
C) Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
D) Iniciar clindamicina oral y realizar aseo quirúrgico de la articulación
E) Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación

PREGUNTA 12 1.04.2.007

**12. Un paciente de 56 años consulta por intenso dolor en rodilla derecha. Al examen se aprecia rodilla derecha eritematosa, caliente y aumentada de volumen. Se realiza artrocentesis, con salida de líquido turbio, poco filante. El estudio citológico demuestra más de 100.000 células, con 90% de polimorfonucleares. La microscopía demuestra cristales escasos de pirofosfato de calcio y la tinción de Gram demuestra cocáceas gran positivas en racimo. El tratamiento de elección es:**

A) Drenaje quirúrgico, asociado a Vancomicina endovenosa
B) Drenaje quirúrgico, asociado a Cloxacilina endovenosa
C) Cefazolina endovenosa, en dosis altas
D) Drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico intraarticular
E) Cefadroxilo por vía oral

PREGUNTA 13 1.11.2.001

**13. Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:**

A) Gota
B) Condrocalcinosis
C) Artritis reumatoidea
D) Artritis séptica
E) Artritis reactiva

PREGUNTA 14 1.05.1.001

**14.** **Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. La radiografía simple de rodilla muestra calcificación de ambos meniscos. Se realiza una artrocentesis, obteniéndose un líquido articular inflamatorio, con visualización de cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva, sin visualización de bacterias. En sus exámenes generales presenta hemograma normal, ácido úrico: 8,0 mg/dl, calcemia: 10 mg/dl, creatinina: 0,8 mg/dl. La conducta más adecuada para el tratamiento agudo y para prevenir nuevas crisis es respectivamente:**

A) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
B) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: No deben indicarse medicamentos
C) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Bifosfonatos
D) Agudo: AINEs y reposo; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol
E) Agudo: AINEs y bifosfonatos; Prevenir nuevas crisis: Alopurinol

PREGUNTA 15 1.05.1.001

**15.** **Un paciente de 70 años presenta una artritis aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido inflamatorio, con 10.000 células por mm3, con abundantes cristales, compatibles con pirofosfato de calcio, sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:**

A) Indicar reposo e iniciar AINES
B) Indicar reposo, iniciar analgésicos y alopurinol
C) Indicar reposo, iniciar analgésicos y bifosfonatos
D) Indicar reposo, iniciar analgésicos, bifosfonatos y alopurinol
E) Indicar reposo, iniciar analgésicos, antibióticos y bifosfonatos

PREGUNTA 16 1.05.1.001

**16.** **Un paciente de 68 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, de 4 horas de evolución, asociado a aumento de volumen. Al examen físico se aprecia enrojecimiento, aumento de la temperatura local y derrame articular, con intenso dolor a la movilización activa y pasiva de la articulación. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra una línea de calcificación del cartílago articular y se realiza estudio del líquido sinovial, demostrándose la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:**

A) Realizar drenaje articular y administrar analgésicos y bifosfonatos
B) Indicar reposo e iniciar analgésicos y bifosfonatos
C) Indicar reposo e iniciar analgésicos y sulfato de magnesio
D) Indicar reposo e iniciar analgésicos y antibióticos empíricos
E) Indicar reposo e iniciar analgésicos

PREGUNTA 17 1.11.1.007

**17.** **Paciente con varios episodios de artritis de rodilla; punción muestra cristales de pirofosfato de calcio intracelulares. ¿Tratamiento para prevenir nuevas crisis?**

A) AINES a demanda
B) Alopurinol
C) Metotrexato oral semanal
D) Infiltración con corticoides
E) Colchicina profiláctica

PREGUNTA 18 1.11.1.004

**18.** **Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritris psoriática
B) Artriris reumatoide
C) Artritis reactiva
D) Condrocalcinosis
E) Artrosis

## BLOQUE 2 ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

PREGUNTA 19 1.05.1.001

**19.** **El lupus inducido por drogas suele presentar:**

A) Anticuerpos anti-DNA de doble hebra
B) Anticuerpos anti-proteína P
C) Anticuerpos anti-Ro
D) Anticuerpos anti-histona
E) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína

PREGUNTA 20 1.05.1.002

**20.** **Un hombre de 40 años presenta rigidez matinal de una hora y artralgias de articulaciones metacarpofalángicas, muñecas y tobillos, desde hace 6 semanas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en las articulaciones descritas. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide
B) Artritis por cristales
C) Artrosis
D) Lupus eritematoso
E) Artritis viral

PREGUNTA 21 1.05.1.002

**21.** **Una paciente de 36 años consulta por artralgias de manos de algunos meses de evolución, asociados a rigidez matinal de 1 hora aproximadamente. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y signos inflamatorios en la mayoría de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos. El diagnóstico más probable es:**

A) Artrosis 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion6
B) Artritis reumatoide
C) Artritis psoriática
D) Lupus sistémico
E) Esclerodermia

PREGUNTA 22 1.05.1.002

**22.** **¿Cuál de las siguientes NO suele ser una manifestación extra articular de la artritis reumatoide?**

A) Fibrosis pulmonar
B) Mielitis transversa
C) Vasculitis de vaso pequeño 18gastroenterologia7
D) Pericarditis
E) Síndrome de Sjörgren secundario

PREGUNTA 23 1.05.1.002

**23.** **¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele aparecer en los pacientes con artritis reumatoide?**

A) Mano en ráfaga
B) Dedos en cuello de cisne
C) Dedos en sastre
D) Nódulos de Heberden
E) Nódulos reumatoídeos

PREGUNTA 24 1.10.1.001

**24.** **Un paciente de 43 años es diagnosticada de artritis reumatoide. El tratamiento de primera línea es:**

A) Indometacina
B) Metotrexato
C) Prednisona
D) Ciclofosfamida
E) Paracetamol

PREGUNTA 25 1.10.1.001

**25.** **¿Cuál de las siguientes alteraciones es menos probable de encontrar en un paciente con artritis reumatoide?**

A) Nódulos reumatoídeos
B) Derrame pleural
C) Nefritis
D) Anemia
E) Miocarditis

PREGUNTA 26 1.10.1.001

**26.** **El tratamiento de elección de la artritis reumatoide es:**

A) Paracetamol
B) AINES
C) Prednisona
D) Metotrexato
E) Prednisona + ciclofosfamida

PREGUNTA 27 1.10.1.001

**27.** **Una paciente de 40 años presenta dolor en las manos desde hace 3 meses. Refiere marcada rigidez articular, que dura cerca de una hora. Al examen físico se aprecia artritis de ambas muñecas y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, de manera bilateral. El tratamiento de elección de la patología descrita es:**

A) Paracetamol
B) Prednisona
C) Ciclofosfamida + corticoides
D) Alopurinol más AINEs
E) Metotrexato

PREGUNTA 28 1.05.1.001

**28.** **¿Qué anticuerpo es más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?**

A) Anti-DNA de una hebra
B) Anti-DNA de dos hebras
C) Anti-Sm
D) Anti-nucleares
E) Anti-citoplasma de neutrófilo

PREGUNTA 29 1.05.1.001

**29.** **Una paciente de 30 años consulta por eritema de la cara, sobre el dorso de la nariz y los pómulos, que respeta el surco nasolabial y que suele aparecer luego de la exposición solar. El diagnóstico más probable es:**

A) Dermatomiositis
B) Esclerodermia
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Lupus discoide
E) Arteritis de Wegener

PREGUNTA 30 1.05.1.001

**30.** **En una paciente de 25 años de edad, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de tres semanas de evolución, caracterizado por compromiso del estado general, fiebre continua, erupción cutánea nasogeniana, alopecía, fenómeno de Raynaud, poliartralgias y derrame pleural, su primera hipótesis diagnóstica es:**

A) Esclerosis Sistémica Progresiva
B) Lupus Eritematoso Sistémico
C) Artritis Reumatoidea
D) Vasculitis
E) Síndrome de Sobreposición

PREGUNTA 31 1.05.1.001

**31.** **Una mujer de 35 años presenta astenia, adinamia, fiebre intermitente, artralgias y caída del cabello, de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones, con signos vitales normales. En en paladar blando se observan 2 úlceras de cerca de 5 mm cada una. Se solicitan exámenes generales, con los siguientes resultados: Hematocrito: 34%; VCM: 30 fl; glóbulos blancos: 4.600 x mm3; neutrófilos: 78%; monocitos: 9%; linfocitos: 13%; plaquetas: 70.000 x mm3; VHS: 44 mm/h; creatinina plasmástica: 2,2 mg/dl; BUN: 28 mg/dl;s hepáticas normales. El diagnóstico más probable es:**

A) Infección por CMV
B) Infección por VIH
C) Leucemia aguda
D) Linfoma
E) Lupus sistémico

PREGUNTA 32 1.11.1.014

**32.** **Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias de varias semanas de evolución, asociada a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa, artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. Se solicitan exámenes, entre los que se encuentran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10 g/dl, leucocitos: 4.000 por mm3, con 15% de linfocitos, además se solicitan ANA (+) en dilución 1:640, Anti-DNA de 2 hebras (+) en dilución 1:160, C3: 60 mg/dl, C4:11 mg/dl, factor reumatoide: 65 U/ml y Anti-CCP (-). El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Vasculitis
E) Dermatomiositis

PREGUNTA 33 1.05.1.001

**33.** **Una paciente de 20 años consulta por fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de manos, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca elevación de la creatinina hasta 2,1 mg/dl y hematuria dismórfica. El diagnóstico más probable es:**

A) Esclerodermia
B) Crioglobulinemia
C) Poliangeítis microscópica
D) Lupus
E) Artritis reumatoide

PREGUNTA 34 1.05.1.001

**34.** **Un hombre de 68 años, diabético tipo 2, en tratamiento con dieta desde hace 10 años, presenta astenia y edema de extremidades inferiores. El examen físico no presenta otras alteraciones. Se solicitan exámenes que constatan un clearence de creatinina de 30 ml/min, BUN: 50 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 1,2 gramos, sedimento de orina con 0-2 glóbulos rojos por campo, sin leucocituria, albuminemia de 4,2 g/dl, HbA1c: 8% y perfil lipídico con 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion/ 4/9 hipercolesterolemia. El diagnóstico más probable es:**

A) Nefropatía diabética
B) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
C) Glomeruloesclerosis difusa
D) Glomerulopatía membranosa
E) Nefritis intersticial

PREGUNTA 35 1.05.1.001

**35.** **Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por orinas espumosas y aumento de volumen facial, especialmente en los párpados. Al examen físico se aprecia edema facial y de extremidades, presión arterial normal, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 0,6 mg/dl, proteinuria de 100 mg/m2/hora, albuminemia: 2,8 g/dl, elevación del colesterol, sedimento de orina normal, ANA negativos, ANCA negativos y complemento normal. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar furosemida
B) Iniciar prednisona
C) Iniciar enalapril
D) Realizar biopsia renal
E) Observar evolución

PREGUNTA 36 1.05.1.001

**36.** **Un paciente de 67 años consulta por artralgias y fiebre de 3 días de evolución, asociados a hematuria y oliguria importante. En sus exámenes generales se aprecia hematuria dismórfica, elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dl, anticuerpos antinucleares negativos y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos en patrón perinuclear. El diagnóstico más probable es:**

A) Poliangeítis microscópica
B) Panarteritis nodosa
C) Vasculitis granulomatosa de Wegener
D) Vasculitis alérgica de Churg-Strauss
E) Arteritis de la temporal Respuestas: Prueba 13 Diabetes y Nutrición + Reumatología Preguntas Respuestas 1 C 2 E 3 C 4 A 5 E 6 A 7 C 8 B 9 D 10 E 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesy-nutricion6 11 E P1re2paración EUNACOM C 13 B 14 B 15 B 16 D 17 E 18 B 19 C 20 A Todos los Derechos Reservados para DrGuevara - 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6

## BLOQUE 3 ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES

PREGUNTA 37 1.01.1.006

**37.** **El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:**

A) Acortamiento del TTPA
B) Trombosis arteriales
C) Trombosis venosasoncologia/ 2/621/12/2016 Prueba 3 | Dr. Guevara
D) Abortos Dr. Guevara
E) Lupus eritematosos sistémico Preparación EUNACOM

PREGUNTA 38 1.01.1.006

**38. Paciente de 34 años con antecedentes de tres abortos previos y trombosis venosa profunda en el último año, sin otros síntomas. Se realiza estudio por sus antecedentes donde destacan ANA (+), anticuerpos antifosfolípidos (+), anticuerpos anticardiolipinas (+) y factor reumatoide (+) ¿Cuál es el manejo más adecuado para la paciente?:**

A) Iniciar tratamiento con prednisona oral
B) Iniciar tratamiento anticoagulante
C) Iniciar tratamiento con metotrexato
D) Iniciar tratamiento con azatioprina
E) Iniciar tratamiento con aspirina

PREGUNTA 39 1.01.1.006

**39. Enferma de 36 años con antecedentes de esplenectomía por trombocitopenia a los 22 años y cuatro abortos, el último seguido de un cuadro de trombosis venosa profunda. Desde hace unas 8 semanas presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre. ¿Cuál de las siguientess de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:**

A) Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
C) Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
D) Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
E) Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

PREGUNTA 40 1.01.1.006

**40. ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?**

A) Mujer con cáncer de mama
B) Mujer diagnosticada de melanoma
C) Mujer con daño hepático crónico por NASH
D) Mujer con déficit de antitrombina III
E) Mujer con antecedente de abortos a repetición

PREGUNTA 41 1.11.1.009

**41. Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica
C) Dermatomiositis
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Enfermedad mixta del tejido conectivo

PREGUNTA 42 1.11.1.021

**42. Mujer joven, aborto hace 3 meses, tiene anemia, hace una TVP confirmada por eco doppler, estudio etiológico:**

A) SAF
B) Estudio Lupus
C) Pedir antitrombina III
D) Estudio TVP??
E) Hemograma y VHS

PREGUNTA 43 1.11.1.023

**43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de túnel carpiano · 1.11.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de túnel carpiano. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 1.05.1.004

**44. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada (CREST) suelen desarrollar:**

A) Fibrosis pulmonar
B) Accidentes vasculares encefálicos
C) Cáncer
D) Hipertensión pulmonar
E) Uveítis

PREGUNTA 45 1.05.1.004

**45. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre marcadores inmunológicos y patología es correcta?**

A) Anticuerpos anti-ribonucleoproteína – Dermatomiositis
B) Anticuerpos anti-proteína P – Actividad lúpica
C) Anticuerpos anti-histona – Enfermedad de Sjörgren
D) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia
E) Anticuerpos antinucleares, patrón citoplasmático – Poliangeítis microscópica

PREGUNTA 46 1.05.1.004

**46. Una paciente de 55 años comienza con disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores. Diez años antes había sido diagnosticada de esclerosis sistémica (ES) debido a la presencia de fenómeno de Raynaud, esclerodermia localizada y la detección de anticuerpos anticentrómero en sangre. Estaba controlada con 7,5 mg de prednisona diarios y cremas vasodilatadoras aplicadas en manos. En su evaluación en el momento de la disnea, la gasometría arterial demostraba hipoxia y en la radiografía de tórax no se veía ninguna afectación parenquimatosa. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente?:**

A) Insuficiencia respiratoria restrictiva muscular.
B) Endocarditis de Libmann Sachs de la tricúspide.
C) Insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a la miocardiopatía de la E.S. 3/endocrinologiadiabetologiaynutriciondiabetesynutricion6
D) Hipertensión pulmonar.
E) Tromboembolismo pulmonar de repetición.

PREGUNTA 47 1.05.1.004

**47.** ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más frecuente en los pacientes con esclerodermia sistémica limitada?

A) Artritis de pequeñas articulaciones
B) Fenómeno de Raynaud
C) Eritema cutáneo
D) Fibrosis pulmonar
E) Insuficiencia renal

PREGUNTA 48 1.11.1.020

**48.** Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Polimialgia reumática
C) Polineuropatía diabética
D) Miopatía por cuerpos de inclusión
E) Síndrome de Guillain Barré

PREGUNTA 49 1.11.1.020

**49.** ¿Qué lesión cutánea es característica de la dermatomiositis?

A) Eritema nodoso
B) Eritema malar
C) Eritema en manto
D) Granuloma anular
E) Pioderma gangrenoso

PREGUNTA 50 1.11.1.020

**50.** ¿Qué marcador suele alterarse con mayor frecuencia en la dermatomiositis?

A) Complemento
B) Factor reumatoídeo
C) Velocidad de sedimentación hemática
D) Anticuerpos antinucleares
E) Creatinfosfoquinasa

PREGUNTA 51 1.11.1.020

**51.** La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, que ha sido asociada a la presencia de un cáncer concomitante. Los marcadores inmunológicos más característicos de esta patología son:

A) Anticuerpos anti centrómero
B) Anticuerpos anti nucléolo
C) Anticuerpos anti Jo-1
D) Anticuerpos anti Ro y anti La
E) Anticuerpos anti ribonucleoproteína

PREGUNTA 52 1.11.1.020

**52.** Acude a su consulta una paciente de 31 años por cuadro de 1 semana de evolución con debilidad en las masas musculares proximales, apareciendo eritema violáceo en párpados superiores y eritema en hombros y región superior del tórax. Usted sospecha una dermatomiositis. ¿Qué marcadores serológicos espera que resulten alterados para confirmar el diagnóstico?

A) Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA) y VHS
B) Anticuerpos antinucleares (ANA) y C3 disminuido
C) Factor reumatoídeo
D) Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1
E) Anticuerpos anti-RNP

PREGUNTA 53 1.05.1.012

**53.** El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

A) Esclerodermia
B) Dermatomiositis
C) Síndrome de Sjörgren
D) Artritis reumatoide
E) Artritis psoriática

PREGUNTA 54 1.11.1.022

**54.** Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgias. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Punción parotidea
B) Biopsia ganglionar
C) Anticuerpos anti-CCP
D) Biopsia de glándula salival accesoria
E) Anticuerpos anti-Sm

## BLOQUE 4 ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET

PREGUNTA 55 1.05.1.001

**55.** Todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante (anquilopoyética) EXCEPTO:

A) Dolor lumbar y rigidez de más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no con el reposo.
B) Sacroileitis radiológica bilateral.
C) Uveítis aguda anterior.
D) Insuficiencia aórtica.
E) Vasculitis de pequeños vasos

PREGUNTA 56 1.05.1.001

**56.** **Hombre de 24 años, deportista. Consulta por dolor glúteo y lumbar de semanas de evolución, que lo despierta en la noche y que se alivia con la actividad. Refiere además talalgia matinal bilateral y una molestia en el tendón aquiliano izquierdo. Ha ingerido antiinflamatorios con disminución parcial y transitoria de los síntomas. Desde ayer nota que el segundo ortejo del pie derecho está rojo y doloroso. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis séptica
B) Pelviespondilopatía
C) Gota
D) Condrocalcinosis
E) Lumbago mecánico

PREGUNTA 57 1.11.1.012

**57.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago infeccioso y tumoral · 1.11.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago infeccioso y tumoral. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 1.11.1.013

**58.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago mecánico · 1.11.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago mecánico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 1.11.1.018

**59.** **Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Radiculopatía S1
B) Espondiloartritis
C) Espondilodiscitis
D) Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar
E) Raquiestenosis

PREGUNTA 60 1.08.1.002

**60.** **Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En alguna ocasión presentó artritis de la rodilla derecha. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilíacas que demuestra signos de sacroileítis bilateral y de algún grado de calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El tratamiento de elección de la patología descrita es:**

A) Corticoesteroides y kinesioterapia
B) Metotrexato y ciclosporina
C) Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios 3/endocrinologia-diabetologiaynutriciondiabetologiaynutriciontraumatologia/ 2/7
D) Metotrexato y ejercicios
E) Ciclosfosfamida y corticoides

PREGUNTA 61 1.08.1.002

**61.** **Un hombre de 23 años presenta dolor lumbar insidioso, mayor al despertar, pero que va disminuyendo, a medida que hace ejercicio. Además presenta sensación febril ocasional. Al examen físico tiene clara limitación a la flexión de la columna lumbar y la radiografía lumbosacra muestra sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos
B) Iniciar costicoides e indicar ejercicios periódicos
C) Iniciar metotrexato e indicar ejercicios periódicos
D) Iniciar hidroxicloroquina e indicar ejercicios periódicos
E) Iniciar ciclosporina e indicar ejercicios periódicos

PREGUNTA 62 1.08.1.002

**62.** **Un hombre de 25 años consulta por lumbago crónico, de predominio nocturno, que cede con el reposo, asociado a rigidez lumbar. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilicas, que muestra signos de sacroileítis y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar ciclosporina
C) Iniciar corticoides orales e indicar ejercicios
D) Iniciar AINES e indicar ejercicios
E) Resolver quirúrgicamente

PREGUNTA 63 1.08.1.002

**63.** **Un paciente de 25 años consulta por dolor lumbar de 4 meses de evolución, que es mayor en la mañana y se asocia a rigidez matinal, cediendo a medida que realiza actividad física. Al examen físico presenta marcada dificultad para flectar la columna, llegando a tocar sólo las rodillas con las extremidades inferiores extendidas. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar aines y reposo relativo, indicando control en caso de recurrencia
B) Iniciar analgésicos, relajantes musculares y kinesioterapia
C) Solicitar radiografía de columna lumbosacra
D) Solicitar RMN de columna lumbosacra
E) Iniciar corticoides orales y ejercicios

PREGUNTA 64 1.11.1.006

**64.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Columna dolorosa · 1.11.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Columna dolorosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 65 1.11.1.001

**65.** **Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectaciónreciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies. ¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?**

A) Reumatoide
B) Reactiva
C) Psoriática
D) Gotosa
E) Lúpica

PREGUNTA 66 1.11.1.001

**66.** **La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:**

A) Una monoartritis aguda migratoria y recidivante
B) Una oligoartritis que compromete las articulaciones cuya piel circundante presenta placas psoriáticas
C) Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis
D) Una poliartritis simétrica distal, de pequeñas y grandes articulaciones, asociadas a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración
E) Una poliartritis de pequeñas articulaciones, asimétrica, asociada a compromiso renal

PREGUNTA 67 1.11.1.001

**67.** **Una mujer de 32 años presenta lesiones en las uñas, consistentes en depresiones puntiformes, similares a picotazos. El diagnóstico más probable es:**

A) Onicomicosis
B) Onicogrifosis
C) Liquen plano
D) Psoriasis
E) Onicocriptosis

PREGUNTA 68 1.11.1.001

**68.** **Una paciente de 40 años presenta artri8s de muñecas y de ar8culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos, de 6 semanas de evolución. Recientemente se agregó dolor y aumento de volumen generalizado del segundo ortejo derecho, que le dificulta la marcha. Al examen Fsico se aprecia aumento de volumen y eritema de las ar8culaciones descritas, más lesiones deprimidas pun8formes en las uñas de las manos, con engrosamiento de las uñas de los pies. El cuadro descrito corresponde a una artri8s de 8po:**

A) Reumatoide
B) Infecciosa
C) Reac2va
D) Psoriá2ca
E) Gotosa

PREGUNTA 69 1.04.1.010

**69.** **Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:**

A) Púrpura trombocitopénico trombótico
B) Síndrome de Reiter
C) Enfermedad de Behcet
D) Vasculitis de Wegener
E) Crioglobulinemia

PREGUNTA 70 1.04.1.010

**70.** **Un paciente de 45 años inicia un cuadro de dolor lumbar insidioso, mayor con el reposo, asociado a artritis de rodillas y manos, con a ojo rojo y disuria dolorosa. Refiere estar utilizando doxiciclina, hace una semana, debido a una enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico más probable es:**

A) Lupus por drogas
B) Síndrome de Reiter
C) Vasculitis leucocitoclástica
D) Reacción fototóxica secundaria al uso de tetraciclinas
E) Espondilitis anquilosante

PREGUNTA 71 1.05.1.015

**71.** **Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y antecedentes de úlceras dolorosas en escroto que dejaron cicatriz. En la exploración oftalmológica se detecta uveítis anterior con nivel de hipopión en cámara anterior. Al realizar unade punción cutánea con aguja estéril en el antebrazo se aprecia a las 36 horas una pápula eritematosa con una pústula estéril central de 3 mm. ¿Cómo se denomina estacutánea diagnóstica?**

A) Prueba de Mitsuda
B) Fenómeno de Patergia
C) Signo de Darier
D) Prueba de Kveim-Siltzbach
E) Signo de Nikolsky

PREGUNTA 72 1.05.1.015

**72.** **¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?**

A) Las úlceras orales son indoloras y las genitales no duelen
B) Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz
C) Las úlceras genitales se acompañan de adenopatías inguinales supurativas
D) Las úlceras orales están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados
E) El tratamiento de elección de las úlceras orales es aciclovir oral

## BLOQUE 5 VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO

PREGUNTA 73 1.11.1.005

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cervicalgia · 1.11.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cervicalgia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.11.1.008

**74.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Epicondilalgia, epitroclealgias · 1.11.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epicondilalgia, epitroclealgias. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.11.1.011

**75. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hombro doloroso · 1.11.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hombro doloroso. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 76 1.11.1.024

**76. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tendonitis y bursitis · 1.11.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tendonitis y bursitis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 77 1.09.1.008

**77. Hombre de 72 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, se asocia a astenia y claudicación mandibular intermitente. Refiere cansancio al peinarse y al realizar otras actividades en las que tenga que mantener los brazos levantados por algunos minutos. El diagnóstico más probable es:**

A) Polimiositis
B) Fibromialgia
C) Arteritis de la temporal
D) Poliangeítis microscópica
E) Panarteritis nodosa

PREGUNTA 78 1.09.1.008

**78. Una paciente de 67 años presenta astenia y debilidad de las extremidades superiores, de predominio proximal, asociada a claudicación mandibular, cefalea frecuente y fiebre ocasional. En sus exámenes generales destaca anemia con marcada elevación de la VHS. El diagnóstico más probable es: 3/endocrinologia-diabetologiaynutriciondiabetesynutricion6**

A) Granulomatosis de Wegener
B) Lupus sistémico
C) Poliangeítis microscópica
D) Arteritis de células gigantes
E) Polimiositis

PREGUNTA 79 1.09.1.008

**79. Un paciente de 65 años presenta astenia y debilidad muscular, especialmente al levantar los brazos y en la musculatura proximal de las extremidades inferiores. También refiere que presenta cefalea frecuente y dolor al masticar por mucho tiempo, lo que lo obliga a comer lento. En sus exámenes destaca anemia normocícita normocrómica, con VHS: 97 mm/h. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar metotrexato
B) Iniciar naproxeno
C) Solicitar angiografía
D) Solicitar ecografía doppler carotídeo
E) Iniciar prednisona 1mg/Kg y solicitar biopsia de arteria temporal

PREGUNTA 80 1.09.1.008

**80. La arteritis de Takayasu se manifiesta con todo lo siguiente, EXCEPTO:**

A) Glomerulonefritis
B) Artralgias6
C) Fiebre
D) Accidente vascular encefálico
E) Asimetría de los pulsos radiales

PREGUNTA 81 1.11.1.025

**81. Un paciente de 75 añosconsulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm3 y VHS: 76 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artritis seronegativa
B) Arteritis de células gigantes
C) Artritis reactiva
D) Lupus
E) Endocarditis aguda

PREGUNTA 82 1.09.1.009

**82. Las vasculitis alérgica de Churg-Strauss, presenta ANCA positivo, en una proporción moderada de los casos. Clínicamente se manifiesta como:**

A) Asma de difícil manejo, que luego se acompaña de glomerulonefritis
B) Exantema purpúrico, de extremidades inferiores, con hematuria, artritis y compromiso gastrointestinas, como hematoquezia por ejemplo
C) Rinosinusitis de difícil manejo, seguida de hemoptisis y glomerulonefritis, con rápido deterioro de la función renal
D) Cefalea, fiebre, amaurosis fugax, claudicación mandibular, polimialgia reumática y elevación de la VHS
E) Exantema pseudopapular (ronchas) muy pruriginoso, con lesiones que confluyen hasta formar grandes placas, afectando las mucosas y asociándose a hipotensión arterial

PREGUNTA 83 1.09.1.009

**83. Un paciente de 32 años presenta una rinosinusitis crónica de difícil manejo, asociado a epistaxis frecuente. En el último tiempo se agrega compromiso del estado general, fiebre, hematuria y oliguria. En sus exámenes destaca ANCA 4/921/12/2016 Prueba 11 | Dr. Guevara positivos en patrón "c". El diagnóstico de sospecha es: Dr. Guevara**

A) Púrpura de Schöenlein-Henoch Preparación EUNACOM
B) Granulomatosis de Wegener
C) Vasculitis de Churg-Strauss
D) Lupus sistémico eritematoso
E) Panarteritis nodosa

PREGUNTA 84 1.09.1.009

**84. La presentación clínica más habitual de la granulomatosis de Wegener es:**

A) Astenia, fiebre, compromiso de coronarias y arterias mesentéricas
B) Glomuronefritis rápidamente progresiva y ANCA positivo en patrón perinuclear
C) Asma refractario a tratamiento y con posterioridad afectación renal
D) Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar
E) Insuficiencia renal, hematuria, accidentes vasculares encefálicos a repetición y púrpura palpable de extremidades inferiores

PREGUNTA 85 1.09.1.009

**85. Un paciente de 65 años consulta por fiebre, artralgias, hematuria, edema de extremidades inferiores y luego anuria. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la creatinina y positividad de los ANCA en patrón perinuclear, a títulos elevados. El diagnóstico más probable es:**

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Granulomatosis de Wegener
C) Arteritis de la temporal
D) Panarteritis nodosa
E) Poliangeítis microscópica

PREGUNTA 86 1.09.1.012

**86. La fibromialgia se caracteriza por:**

A) Asociarse a anemia
B) Asociarse a cáncer
C) Presentar elevación de la VHS
D) Dolor a la presión de las masas musculares
E) Presentar positividad de los anticuerpos antinucleares

PREGUNTA 87 1.09.1.012

**87. Un paciente de 58 años, con antecedentes de síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y fibromialgia, consulta por molestias faríngeas fluctuantes, de larga evolución. Refiere que siente como si tuviera una pelota en la faringe, la que no puede tragar (globus). Al examen físico no se aprecian alteraciones. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno conversivo
B) Depresión
C) Hipocondría
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno de personalidad dependiente

PREGUNTA 88 1.11.1.010

**88. Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar biopsia muscular
B) Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)
E) Iniciar metotrexato oral

PREGUNTA 89 1.09.1.014

**89. Una paciente de 40 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,6 y un Z-score: -2,0. El diagnóstico más probable es:**

A) Sana
B) Osteopenia
C) Osteoporosis postmenopáusica
D) Osteoporosis secundaria
E) Enfermedad de Paget

PREGUNTA 90 1.11.1.017

**90.** **Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una den- sitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la co- lumna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquí- mico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más ade- cuada para esta paciente?**

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina endovenosa
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ARTRITIS INFLAMATORIAS, CRISTALES Y DIAGNÓSTICO ARTICULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A Oligoartritis

1.11.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Oligoartritis" (1.11.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A Poliartritis

1.11.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Poliartritis" (1.11.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 Respuesta: D

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

El caso describe un paciente de 70 años con un cuadro agudo de monoartritis inflamatoria severa en la rodilla, caracterizado por dolor muy intenso, aumento de volumen, calor y eritema, y un derrame articular. La radiografía muestra condrocalcinosis (línea de calcificación en el cartílago articular), un hallazgo clave. La artrocentesis revela un líquido sinovial inflamatorio (10.000 células con 90% de polimorfonucleares), y lo más importante, la microscopía de campo oscuro identifica **múltiples cristales con birrefringencia de elongación positiva**. Esta combinación de condrocalcinosis radiológica y la presencia de cristales con birrefringencia positiva en el líquido sinovial es patognomónica de la **artritis por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como pseudogota. La tinción de Gram negativa ayuda a disminuir la sospecha de artritis séptica, aunque no la descarta por completo sin un cultivo. El manejo de una crisis aguda de pseudogota se centra en el control rápido de la inflamación y el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son la primera línea de tratamiento y son muy efectivos. Dada la intensidad del dolor ("dolor muy intenso") y la severidad del cuadro inflamatorio, la administración endovenosa de AINEs es una opción apropiada para lograr un efecto más rápido y potente. El reposo de la articulación afectada es una medida complementaria importante que contribuye a reducir la inflamación y el malestar. Por lo tanto, la opción de iniciar AINEs endovenosos y reposo aborda de manera directa y efectiva la crisis aguda de pseudogota, proporcionando alivio rápido al paciente.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

El paciente presenta un cuadro clínico, radiológico y de laboratorio clásico de una artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado (CPPD), también conocida como pseudogota. El diagnóstico se fundamenta en la triada de: 1) monoartritis aguda en una persona mayor, 2) la presencia de condrocalcinosis (calcificación de los meniscos) en la radiografía, que es un hallazgo muy sugerente, y 3) el hallazgo confirmatorio en el líquido sinovial de cristales con birrefringencia débilmente positiva bajo luz polarizada. La ausencia de bacterias en el estudio del líquido descarta una artritis séptica, que es el principal diagnóstico diferencial. El objetivo del tratamiento en la fase aguda de la pseudogota es controlar la intensa respuesta inflamatoria y aliviar el dolor. La primera línea de tratamiento consiste en el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el naproxeno o la indometacina, siempre que no existan contraindicaciones (insuficiencia renal, úlcera péptica activa, etc.). Junto con el tratamiento farmacológico, el reposo de la articulación afectada es fundamental para disminuir la inflamación y el dolor. Otras opciones para el manejo agudo incluyen la colchicina o los corticoides (intraarticulares o sistémicos), pero los AINEs y el reposo son la estrategia inicial más común y adecuada, tal como se plantea en la opción correcta. Es importante destacar que la hiperuricemia (ácido úrico de 8,0 mg/dl) es un distractor. Aunque puede coexistir, el tipo de cristal identificado en la artrocentesis (birrefringencia positiva) descarta la gota (cuyos cristales de urato monosódico tienen birrefringencia negativa) como causa del episodio agudo actual. Por lo tanto, el tratamiento debe dirigirse a la pseudogota y no a la gota.

**PREGUNTA 5** **Respuesta: D**

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

1.11.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter.

---

**PREGUNTA 6** **Respuesta: D**

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

1.11.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Anticuerpos anti-CCP

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: D**

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

1.11.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una monoartritis aguda, que se estudia con punción. Por clínica, probablemente será una condrocalcinosis, pero también puede ser una artritis séptica, por lo que es fundamental la punción.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: D**

**Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial**

1.11.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La colchicina tiene muchos efectos adversos, por lo que se prefiere no dejarla como tratamiento profiláctico, sino solo en las crisis agudas (en agudo los AINEs son de elección). EL alopurinol debe mantenerse, ya que tuvo más de 2 crisis en 1 año y actualmente tiene buenos niveles de ácido úrico.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: E**

**Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un caso de artritis séptica en un adolescente, caracterizada por síntomas de artritis de tobillo derecho y un estudio de líquido sinovial altamente sugerente de infección. Los hallazgos del líquido sinovial (aspecto turbio, poco filante, alta celularidad de 85.000 células/mm3 con 95% de polimorfonucleares) son clásicos de una artritis séptica grave. La clave diagnóstica y terapéutica reside en la visualización de "abundantes cocáceas Gram negativas intracelulares". En un adolescente, la presencia de cocáceas Gram negativas en el líquido sinovial de una articulación séptica apunta fuertemente a *Neisseria gonorrhoeae* como el agente etiológico, causante de una infección gonocócica diseminada (IGD) que se manifiesta como artritis. Otros patógenos Gram negativos son posibles, pero *Neisseria* es la principal sospecha con esta descripción y en este grupo etario. El tratamiento de elección para la artritis gonocócica, y en general para la mayoría de las artritis sépticas por Gram negativos no entéricos, es ceftriaxona. Este antibiótico es una cefalosporina de tercera generación con excelente cobertura contra *Neisseria gonorrhoeae* y buena penetración en el líquido sinovial. Además de la terapia antibiótica, el drenaje de la articulación es un pilar fundamental en el manejo de la artritis séptica. La acumulación de pus y bacterias dentro de la articulación puede causar daño irreversible al cartílago y al hueso subcondral. El drenaje, que puede ser mediante aspiraciones repetidas con aguja o, en casos más severos o con mala respuesta, mediante artroscopia o artrotomía quirúrgica, es esencial para remover el material purulento, reducir la presión intraarticular, disminuir la carga bacteriana y mejorar la eficacia de los antibióticos. Por lo tanto, la combinación de ceftriaxona endovenosa y drenaje quirúrgico es la conducta más adecuada y urgente para preservar la función articular.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: C**

**Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **Neisseria gonorrhoeae** debido a la presentación clínica clásica de artritis séptica monoarticular aguda en una persona sexualmente activa, el hallazgo de diplococos Gram negativos intracelulares en la tinción del líquido sinovial, y el potencial de cultivo negativo debido a los requerimientos nutricionales específicos del organismo y la posible presencia de antibióticos. La gonorrea es una causa importante de artritis séptica, especialmente en adultos jóvenes y sexualmente activos. La diseminación hematógena del gonococo puede ocurrir, llevando a una artritis, que a menudo afecta a las articulaciones grandes como la rodilla. La identificación de cocáceas Gram negativas intracelulares en la muestra de líquido articular es altamente sugestiva de infección gonocócica. Aunque el cultivo del líquido sinovial puede ser negativo en algunos casos de artritis gonocócica, especialmente si se han administrado antibióticos previos o si el patógeno es difícil de cultivar, el cuadro clínico y la citología del líquido sinovial son cruciales para el diagnóstico. Otros métodos diagnósticos, como la PCR en líquido sinovial o en muestras de uretra, cérvix o faringe, pueden ser más sensibles en estos casos. La clave para diferenciar esta presentación de otras artritis sépticas bacterianas reside en la morfología y tinción de los microorganismos observados.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: E**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos**

La respuesta correcta es la **E** porque aborda de manera integral y urgente los dos pilares fundamentales en el manejo de la artritis séptica: el tratamiento antibiótico adecuado y el drenaje articular efectivo. Primero, el hallazgo de "cocáceas Gram positivas dispuestas en racimo" es la descripción clásica de *Staphylococcus aureus*, el agente causal más frecuente de artritis séptica en adultos. La cefazolina, una cefalosporina de primera generación, ofrece una excelente cobertura contra *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina (SASM), que es la cepa más común en infecciones adquiridas en la comunidad. La administración endovenosa (EV) es crucial para alcanzar concentraciones terapéuticas altas y rápidas en la articulación. Segundo, y de igual importancia, es el aseo quirúrgico. La articulación de la cadera es profunda, de difícil acceso y no compresible, lo que hace que el drenaje por punciones repetidas (artrocentesis) sea ineficaz y riesgoso. Un drenaje incompleto del material purulento no solo perpetúa la infección, sino que las enzimas proteolíticas presentes en el pus destruyen el cartílago articular rápidamente, llevando a secuelas funcionales severas. Además, el aumento de la presión intraarticular en la cadera puede comprometer la irrigación de la cabeza femoral, provocando una osteonecrosis avascular. Por lo tanto, el aseo quirúrgico (ya sea por artrotomía o artroscopía) es el estándar de oro para la artritis séptica de cadera, ya que permite un drenaje completo, lavado de la articulación y desbridamiento del tejido necrótico. La combinación de cefazolina EV y aseo quirúrgico es la terapia óptima y urgente para este paciente.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

1.04.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos**

La presentación clínica de un paciente con intenso dolor en la rodilla, eritema, calor y aumento de volumen, junto con líquido articular turbio y una citología con gran cantidad de polimorfonucleares, es altamente sugestiva de una artritis séptica. El hallazgo microscópico de cocáceas grampositivas en racimo en la tinción de Gram es crucial, ya que orienta fuertemente hacia la presencia de *Staphylococcus aureus*, el agente etiológico más común de la artritis séptica en adultos, especialmente en presencia de factores de riesgo como la edad avanzada. Dada la etiología probable y la gravedad de la infección articular, el manejo debe ser agresivo. El drenaje quirúrgico de la articulación es fundamental para eliminar el material purulento, los detritos y reducir la carga bacteriana, lo que mejora significativamente el pronóstico y previene el daño articular crónico. La elección del antibiótico endovenoso debe dirigirse contra *Staphylococcus aureus*, siendo la cloxacilina un betalactámico resistente a las penicilinasas, eficaz contra la mayoría de las cepas de *S. aureus* meticilín-sensible (SAMR). Por lo tanto, el drenaje quirúrgico asociado a cloxacilina endovenosa representa el tratamiento de elección.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: D**

1.11.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos**

La fiebre y que afecte el hombro, orienta mucho a que es una A. séptica. Faltan datos como para pensar en condrocalcinosis que es otra de las causas de monoartritis aguda (afectan más otras articulaciones: rodilla en condrocalcinosis).

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)**

El caso clínico describe a un paciente de 69 años con una monoartritis aguda de rodilla. Las claves diagnósticas son la radiografía que muestra **calcificación de ambos meniscos (condrocalcinosis)** y, sobre todo, la artrocentesis que revela **cristales abundantes con birrefringencia de elongación positiva**. Estos hallazgos son patognomónicos de la **artropatía por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD)**, comúnmente conocida como **pseudogota**. A diferencia de la gota, donde los cristales de urato monosódico presentan birrefringencia negativa, los cristales de CPPD son positivos. Los exámenes generales, incluyendo calcemia y creatinina normales, y un ácido úrico discretamente elevado pero no directamente relacionado con la causa de esta artropatía cristalina (dado el tipo de cristales identificados), apoyan el diagnóstico de pseudogota. Para el **tratamiento agudo** de una crisis de pseudogota, las opciones de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o la colchicina, junto con medidas de soporte como el reposo y la crioterapia. La inyección intraarticular de corticoides es también una opción muy efectiva, especialmente si la articulación es grande y accesible. Por lo tanto, indicar AINEs y reposo es una conducta adecuada para el manejo de la fase aguda. En cuanto a la **prevención de nuevas crisis** de pseudogota, es fundamental entender que, a diferencia de la gota (donde el alopurinol se usa para reducir el ácido úrico y prevenir ataques), no existe un tratamiento farmacológico específico y universalmente establecido para prevenir la formación de cristales de CPPD o la recurrencia de las crisis. La gestión se centra en identificar y tratar enfermedades subyacentes asociadas (como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia), pero en este paciente no se reportan antecedentes ni alteraciones en los exámenes que sugieran estas condiciones como causa. En ausencia de una causa secundaria tratable o de crisis muy frecuentes y debilitantes (donde la colchicina a dosis bajas podría considerarse off-label para profilaxis), la recomendación general es **no indicar medicamentos específicos** para prevenir nuevas crisis de CPPD, ya que no hay terapias probadas que modifiquen el curso de la enfermedad de depósito de cristales de CPPD.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)**

La alternativa correcta es la A (Indicar reposo e iniciar AINES). El caso describe una condrocalcinosis (artritis por pirofosfato de calcio), también conocida como pseudogota. La clínica aguda se manifiesta con inflamación articular, dolor y derrame. El análisis del líquido sinovial es clave para el diagnóstico, mostrando cristales de pirofosfato de calcio. El tratamiento de la crisis aguda se basa en medidas no farmacológicas (reposo, hielo) y farmacológicas, siendo los AINES la primera línea por su efecto antiinflamatorio. Otras opciones incluyen colchicina (especialmente si hay contraindicación para AINES) e incluso corticoides intraarticulares si el compromiso es monoarticular y severo. Es importante mencionar que el tratamiento con alopurinol y bifosfonatos no están indicados en el manejo agudo de la condrocalcinosis.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: E**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)**

La pregunta describe un caso clínico clásico de una artropatía por depósito de cristales, específicamente un ataque agudo de pseudogota o enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio (CPPD). El paciente es un hombre de 68 años con un cuadro de monoartritis aguda de la rodilla izquierda, caracterizado por dolor intenso, aumento de volumen, enrojecimiento y aumento de la temperatura local, junto con derrame articular. La radiografía de rodilla muestra una "línea de calcificación del cartílago articular", conocida como condrocalcinosis, que es una característica distintiva de la CPPD. El estudio del líquido sinovial confirma el diagnóstico al demostrar la presencia de abundantes cristales con birrefringencia de elongación positiva, lo que es patognomónico de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado (CPPD). Además, la tinción de Gram negativa descarta una artritis séptica, que es un diagnóstico diferencial crucial en cualquier monoartritis aguda. Ante un ataque agudo de pseudogota, el tratamiento principal se centra en el alivio del dolor y la inflamación. Los medicamentos de primera línea incluyen los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), la colchicina y los corticosteroides (orales o intraarticulares). La opción (e) "Indicar reposo e iniciar analgésicos" es la conducta más adecuada y general, ya que el reposo de la articulación afectada ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, y los analgésicos (que en este contexto incluirían los AINEs como tratamiento de primera línea) son esenciales para manejar la sintomatología. Aunque la aspiración del líquido sinovial puede ser diagnóstica y terapéutica para aliviar la presión, no es siempre estrictamente necesaria como parte del tratamiento inicial en todos los casos y no se menciona como una opción aislada y correcta para el manejo del dolor.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: E**

1.11.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)**

Colchicina profiláctica

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: E**

1.11.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada**

Tanto la clínica (compromiso de IFD, IFP y primera CMC), como la radiografía son clásicas de artrosis. No importa la positividad de marcadores, ya que están positivos en un 5% de las personas sanas y solo tienen importancia cuando la clínica es de Lupus o Artritis reumatoide, que no es el caso.

---

## BLOQUE 2 ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas**

El lupus inducido por drogas (LID) es un síndrome que se asemeja al lupus eritematoso sistémico (LES), pero es causado por la exposición crónica a ciertos medicamentos. A diferencia del LES idiopático, el LID tiende a ser menos grave, rara vez involucra los riñones o el sistema nervioso central, y sus síntomas suelen resolver semanas o meses después de la interrupción del fármaco causante. Las manifestaciones clínicas comunes incluyen artralgias, mialgias, fiebre, erupciones cutáneas y serositis (pleuritis o pericarditis). La característica serológica más distintiva y la respuesta correcta para el diagnóstico de lupus inducido por drogas son los anticuerpos anti-histona. Estos anticuerpos están presentes en más del 95% de los pacientes con LID, lo que los convierte en un marcador altamente sensible para esta condición. Se dirigen a las proteínas histonas que forman parte del nucleosoma, la unidad fundamental de empaquetamiento del ADN. La presencia de anticuerpos anti-histona, junto con una historia de exposición a medicamentos conocidos por inducir lupus (como hidralazina, procainamida, isoniacida, minociclina, anti-TNF-alfa, entre otros) y la resolución de los síntomas tras la interrupción del fármaco, son los pilares para el diagnóstico de LID.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La alternativa correcta es Artritis Reumatoide (AR) debido a la presentación clínica del paciente. Los hallazgos clave que apuntan hacia AR son: * **Rigidez matinal de una hora o más:** Este es un sello distintivo de la AR, causado por la acumulación de líquido inflamatorio en las articulaciones durante la noche. La duración de la rigidez es importante; una rigidez menor a 30 minutos es menos sugestiva de AR. * **Artralgias de pequeñas articulaciones:** La AR tiende a afectar las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), muñecas y tobillos. La afectación simétrica de estas articulaciones es también muy característica. * **Duración de los síntomas:** El paciente presenta los síntomas desde hace 6 semanas. Para cumplir los criterios diagnósticos de AR, los síntomas deben estar presentes por lo menos 6 semanas. * **Signos inflamatorios:** Aumento de volumen y signos inflamatorios (dolor, calor, rubor) en las articulaciones afectadas confirman la presencia de sinovitis, un proceso inflamatorio característico de la AR. En Chile, el MINSAL cuenta con guías clínicas para el manejo de la Artritis Reumatoide, enfocándose en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para minimizar el daño articular y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si bien no se cita textualmente un extracto en esta explicación, es fundamental conocer y aplicar los criterios diagnósticos y de tratamiento establecidos en dichas guías.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: B**

**Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es b) Artritis reumatoide. La paciente presenta una constelación de síntomas y signos altamente sugestivos de artritis reumatoide (AR). Clásicamente, la AR afecta a mujeres en edad adulta (la paciente tiene 36 años), se caracteriza por una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, especialmente las interfalángicas proximales (IFP) y metacarpofalángicas (MCF) de las manos, tal como se describe. El "aumento de volumen y signos inflamatorios" en estas articulaciones es la manifestación de una sinovitis crónica. Un hallazgo cardinal que distingue a la artritis inflamatoria, como la AR, de otras condiciones es la rigidez matinal prolongada. En este caso, la rigidez de "1 hora aproximadamente" es muy característica de la AR, donde la rigidez suele durar más de 30 minutos o incluso varias horas. La evolución de "algunos meses" también es consistente con el curso crónico y progresivo de la enfermedad. Todos estos elementos en conjunto apuntan inequívocamente hacia la artritis reumatoide como el diagnóstico más probable.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

**Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La mielitis transversa, aunque una manifestación neurológica seria, no es una complicación extraarticular típica de la artritis reumatoide (AR). Si bien la AR puede asociarse a manifestaciones neurológicas, estas suelen ser secundarias a la inflamación directa de nervios (neuropatía periférica, como la mononeuritis múltiple) o a la compresión por estructuras inflamadas (como el síndrome del túnel carpiano), y no a una inflamación primaria de la médula espinal como la mielitis transversa. La mielitis transversa es más comúnmente asociada a otras enfermedades autoinmunes (como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica), infecciones o, de forma idiopática.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: D**

**Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la **d) Nódulos de Heberden**. Los nódulos de Heberden son formaciones óseas o cartilaginosas que aparecen típicamente en las articulaciones interfalángicas distales (IFD) de los dedos de las manos. Son un signo patognomónico de la **artrosis (osteoartritis)**, una enfermedad degenerativa articular, y no de la artritis reumatoide. Su presencia se debe al crecimiento de osteofitos en el borde de la articulación afectada por el desgaste del cartílago y la reacción ósea subyacente. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones sinoviales, causando sinovitis persistente que puede llevar a la destrucción del cartílago y el hueso, así como a la deformidad articular. Aunque la AR también puede afectar las manos y causar deformidades significativas, los nódulos de Heberden no forman parte de su cuadro clínico característico. La diferenciación entre estas dos condiciones, la artrosis y la artritis reumatoide, es fundamental en reumatología y se basa en la etiología, patogenia, patrones de afectación articular y la presencia de hallazgos específicos como los nódulos de Heberden en la artrosis.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES**

El metotrexato es, de hecho, el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) de primera línea y pilar fundamental en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR) de moderada a grave. Su eficacia radica en su capacidad para reducir la inflamación, disminuir el daño articular progresivo y mejorar la función física en la mayoría de los pacientes. Se clasifica como un antimetabolito que actúa como un antagonista del folato, inhibiendo la dihidrofolato reductasa, lo que interfiere con la síntesis de purinas y pirimidinas y, en última instancia, con la proliferación de células inflamatorias como los linfocitos T y B. Su mecanismo de acción inmunomodulador es clave para controlar la actividad de la enfermedad a largo plazo. La administración de metotrexato suele ser semanal (oral o subcutánea) y se recomienda iniciarla lo antes posible tras el diagnóstico para prevenir la progresión del daño articular. Para mitigar los efectos secundarios relacionados con la depleción de folato (como náuseas, estomatitis, o elevación de enzimas hepáticas), se coadministra suplementación con ácido fólico. Antes de iniciar el tratamiento, y de forma regular durante el mismo, se deben realizar controles hepáticos y renales, así como hemogramas, para monitorizar la seguridad del fármaco. La elección de metotrexato como primera línea se basa en su perfil de eficacia bien establecido, su tolerabilidad en la mayoría de los pacientes y su costo-efectividad. Si un paciente no responde adecuadamente a metotrexato en monoterapia, o presenta contraindicaciones, se pueden considerar combinaciones con otros FARME (como hidroxicloroquina o sulfasalazina) o la escalada a terapias biológicas o inhibidores de JAK, siempre manteniendo el metotrexato como base si es posible.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: C**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES**

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune sistémica que, además de afectar principalmente las articulaciones, puede manifestarse con una amplia gama de complicaciones extraarticulares que comprometen diversos órganos. La pregunta busca identificar cuál de las alteraciones presentadas es la "menos probable" de encontrar en un paciente con AR. Las manifestaciones renales directas de la AR, específicamente la nefritis glomerular inflamatoria primaria, son considerablemente menos comunes y menos características que en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Aunque los pacientes con AR pueden desarrollar problemas renales, estos suelen ser secundarios a otras causas. La amiloidosis AA, una complicación grave de la inflamación crónica no controlada en la AR, puede llevar a depósitos de amiloide en los riñones, resultando en proteinuria y eventual insuficiencia renal. Del mismo modo, la nefrotoxicidad inducida por los medicamentos utilizados para tratar la AR (como AINEs, metotrexato o ciclosporina) es una causa frecuente de disfunción renal en estos pacientes. Por lo tanto, si bien las alteraciones renales pueden ocurrir en el contexto de la AR (principalmente por amiloidosis o fármacos), la nefritis (entendida como una glomerulonefritis primaria y directa causada por la AR) no es una manifestación patológica típica ni frecuente de la enfermedad en sí misma, a diferencia de las otras opciones que son manifestaciones extraarticulares bien reconocidas y características de la artritis reumatoide.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: D**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES**

El metotrexato (MTX) es considerado el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) convencional de primera línea y tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide (AR). Su importancia radica en su capacidad para modificar el curso de la enfermedad, reduciendo la inflamación, controlando la progresión del daño articular y mejorando la función física y la calidad de vida a largo plazo. A diferencia de los tratamientos sintomáticos, el metotrexato busca detener la patogénesis de la enfermedad. El mecanismo de acción del metotrexato en la AR no se comprende completamente, pero se cree que involucra la inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo que afecta el metabolismo del folato y la proliferación celular, especialmente en células inmunes activadas. También posee efectos antiinflamatorios directos y modula la función de las células T y la producción de citocinas proinflamatorias. Su eficacia y un perfil de seguridad bien establecido (cuando se monitoriza adecuadamente) lo convierten en el "fármaco ancla" en el manejo de la AR, utilizándose frecuentemente como monoterapia inicial o como parte fundamental de terapias combinadas con otros FARME o terapias biológicas.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: E**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES**

La paciente presenta un cuadro clínico característico de Artritis Reumatoidea (AR): poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones (muñecas, MCF, IFP), rigidez matinal prolongada (mayor a 30 minutos, en este caso una hora). Según las guías clínicas chilenas (y consensos internacionales), el tratamiento de primera línea para la AR es un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME) sintético convencional, siendo el Metotrexato (MTX) el más utilizado y con mayor evidencia de eficacia y seguridad. Su uso temprano disminuye la progresión del daño articular y mejora la calidad de vida.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: D**

**Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es d) Anti-nucleares (ANA) porque son los anticuerpos más sensibles para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES). Los anticuerpos anti-nucleares son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del núcleo celular y están presentes en más del 95% de los pacientes con LES, a menudo incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Esta alta sensibilidad los convierte en la prueba de cribado o "screening" inicial ideal para la sospecha de LES. Un resultado ANA negativo (con la técnica y títulos adecuados) prácticamente descarta el diagnóstico de LES. Es importante destacar que, si bien la prueba ANA es extremadamente sensible, no es específica para el LES. Un resultado positivo puede encontrarse en otras enfermedades autoinmunes (como esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide), infecciones, cáncer, e incluso en un porcentaje de individuos sanos, especialmente con la edad avanzada o el uso de ciertos fármacos. Por lo tanto, un ANA positivo siempre debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente y, si la sospecha de LES persiste, debe complementarse con la búsqueda de anticuerpos más específicos. En resumen, los ANA son el primer paso en la evaluación diagnóstica del LES debido a su capacidad para identificar a casi todos los pacientes con la enfermedad, actuando como una puerta de entrada para pruebas más confirmatorias. Su rol es fundamentalmente el de una herramienta de screening con un alto valor predictivo negativo, lo que permite descartar el diagnóstico de LES cuando el resultado es negativo.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

**Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La descripción del eritema facial en la paciente, caracterizado por un eritema en el dorso de la nariz y los pómulos, respetando el surco nasolabial, que se exacerba con la exposición solar, es altamente sugestivo del "rash malar" o "eritema en alas de mariposa". Este rash es un criterio diagnóstico importante para el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**, según los criterios SLICC o EULAR/ACR. Si bien el lupus discoide también puede presentar un rash facial, este suele ser más indurado, escamoso y deja cicatriz, lo que no se describe en el caso clínico. Además, el LES es una enfermedad sistémica, y el rash facial puede ser la primera manifestación. Es fundamental, ante la sospecha de LES, solicitar exámenes complementarios como ANA, anti-DNA, anti-Sm, complemento, etc., para confirmar el diagnóstico y evaluar el compromiso de otros órganos. **En Chile, la Guía Clínica GES de Lupus Eritematoso Sistémico (MINSAL) enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario del LES, destacando la presentación clínica inicial, incluyendo el rash malar, como un signo de alerta.**

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

**Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) porque el cuadro clínico que presenta la paciente es altamente sugestivo de esta enfermedad. Los síntomas clave que apuntan al LES son: * **Compromiso del estado general y fiebre continua:** Son síntomas comunes en enfermedades autoinmunes sistémicas como el LES. * **Erupción cutánea nasogeniana:** Esta descripción sugiere el clásico "eritema en alas de mariposa" o rash malar, muy característico del LES. * **Alopecía:** La pérdida de cabello también es una manifestación frecuente del LES. * **Fenómeno de Raynaud:** Presente en un porcentaje significativo de pacientes con LES. * **Poliartralgias:** El dolor en múltiples articulaciones es otro síntoma común en el LES. * **Derrame pleural:** La serositis, que se manifiesta como derrame pleural (o pericárdico), es un criterio diagnóstico de LES. Según la Guía Clínica del MINSAL para el Lupus Eritematoso Sistémico (si bien, no se puede citar directamente sin el link/archivo), el diagnóstico de LES se basa en una combinación de criterios clínicos y de laboratorio. Los síntomas presentados por la paciente cumplen con varios de estos criterios. Es fundamental solicitar exámenes complementarios (ej. ANA, anti-DNA, complemento) para confirmar el diagnóstico.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: E**

**Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La paciente presenta un cuadro clínico caracterizado por síntomas constitucionales (astenia, adinamia, fiebre intermitente), artralgias y alopecia, lo que sugiere una enfermedad autoinmune. Además, presenta úlceras orales, que son un criterio diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) según los criterios SLICC y EULAR. Los hallazgos de laboratorio son altamente sugestivos de LES: anemia (hematocrito bajo y VCM disminuido, pudiendo ser anemia de enfermedad crónica o relacionada al LES), trombocitopenia (plaquetas bajas) y elevación de la creatinina (sugiere compromiso renal, una manifestación frecuente del LES). La elevación de la VHS también es un hallazgo compatible con inflamación sistémica. Es importante destacar que, si bien no se mencionan explícitamente los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o anti-Sm, la presencia de estos elementos clínicos y de laboratorio justifica considerar LES como el diagnóstico más probable. La guía clínica del MINSAL para el LES enfatiza la importancia de la detección temprana y tratamiento oportuno para prevenir daño orgánico irreversible.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: C**

**Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal**

1.11.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene muchas cosas de lupus sistémico: úlceras orales, rash malar, linfocitos bajo, ANA+, anti-DNA+, hipocomplementemia.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: D**

**Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es Lupus Eritematoso Sistémico (LES) debido a la combinación de síntomas y hallazgos de laboratorio presentados. La paciente de 20 años presenta: * **Fiebre y Astenia:** Síntomas constitucionales comunes en enfermedades autoinmunes como el LES. * **Artralgias y Artritis de manos:** La artritis en pequeñas articulaciones como las manos es característica de enfermedades autoinmunes. * **Hematuria:** Sugiere afectación renal, lo cual es frecuente en el LES, específicamente la nefritis lúpica. * **Elevación de la Creatinina:** Indica insuficiencia renal, lo que apoya aún más la posibilidad de nefritis lúpica. * **Hematuria Dismórfica:** Apoya la afectación glomerular, lo cual es característico de la nefritis lúpica. La nefritis lúpica es una manifestación grave del LES, y la hematuria y la elevación de la creatinina son hallazgos importantes para sospecharla. Según la guía clínica del MINSAL sobre Lupus Eritematoso Sistémico (si bien no existe una guía específica del MINSAL para LES, las guías de manejo de enfermedades autoinmunes del MINSAL generalmente recomiendan una evaluación exhaustiva ante sospecha de compromiso renal), la presencia de compromiso renal obliga a una evaluación diagnóstica completa que incluye biopsia renal para confirmar el diagnóstico y determinar el grado de afectación.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: A**

**Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El diagnóstico más probable es nefropatía diabética debido a la constelación de hallazgos clínicos y de laboratorio en un paciente con un factor de riesgo claro y de larga data. Se trata de un hombre con 10 años de evolución de diabetes mellitus tipo 2 y un control glucémico deficiente (HbA1c: 8%), lo cual es el principal factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones microvasculares, incluyendo el daño renal. La presentación clínica con astenia y edema de extremidades inferiores es compatible con una enfermedad renal crónica (ERC) avanzada, donde la astenia puede ser secundaria a la uremia (BUN elevado) y/o anemia de la ERC, y el edema se explica por la retención de sodio y agua debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Los exámenes de laboratorio confirman la presencia de una ERC avanzada con características típicas de la nefropatía diabética. Un clearence de creatinina de 30 ml/min lo sitúa en una etapa G4 de ERC. La proteinuria de 1,2 gramos en 24 horas corresponde a una proteinuria en rango nefrótico (o macroalbuminuria), un sello distintivo de esta complicación. Es crucial notar que el sedimento de orina es "blando", es decir, sin hematuria ni leucocituria significativas, lo que es característico de la nefropatía diabética y ayuda a descartar glomerulonefritis activas o nefritis intersticiales. Aunque la albuminemia es normal, esto no descarta el diagnóstico, ya que el síndrome nefrótico completo (proteinuria >3.5g/día, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia) no siempre está presente. La combinación de diabetes de larga evolución, mal control, ERC y proteinuria con sedimento blando hace que la nefropatía diabética sea la principal sospecha, sin necesidad inicial de una biopsia renal.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

**Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El caso clínico describe a un niño de 6 años con un cuadro clásico de **Síndrome Nefrótico Idiopático (SNI)**. Los elementos clave que apoyan este diagnóstico son: 1. **Presentación clínica:** Edema de inicio insidioso, con predominio facial y palpebral ("anasarca"), y orinas espumosas (signo de proteinuria masiva). 2. **Tétrada del Síndrome Nefrótico:** * **Proteinuria en rango nefrótico:** 100 mg/m2/hora (el criterio es >40 mg/m2/hora). * **Hipoalbuminemia:** 2.8 g/dl (el criterio es <3.0 g/dl, aunque clásicamente se usa <2.5 g/dl). * **Edema:** Presente en el examen físico. * **Hiperlipidemia:** Mencionada como "elevación del colesterol" (es una consecuencia de la hipoalbuminemia, por aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas). 3. **Ausencia de signos nefríticos:** El paciente tiene presión arterial normal, creatinina normal (función renal conservada) y un sedimento de orina normal (sin hematuria ni cilindros), lo que aleja la sospecha de un síndrome nefrítico. 4. **Estudio inmunológico negativo:** ANA, ANCA y complemento normales descartan causas secundarias comunes como lupus o vasculitis. En niños de 1 a 10 años con esta presentación clásica, la causa más probable (aproximadamente 90% de los casos) es la **Enfermedad de Cambios Mínimos (ECM)**. Esta patología se caracteriza por su excelente respuesta a los corticoides. Por lo tanto, el manejo inicial estándar y de primera línea, sin necesidad de una biopsia previa, es iniciar un ciclo de **prednisona** oral a dosis altas (60 mg/m2/día o 2 mg/kg/día) con el objetivo de inducir la remisión.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

**Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta un cuadro clínico altamente sugestivo de una vasculitis sistémica que afecta predominantemente los vasos pequeños, manifestándose como una glomerulonefritis rápidamente progresiva (RPGN). Esto se evidencia por la oliguria importante, la elevación aguda de la creatinina a 3,5 mg/dl (indicando lesión renal aguda severa) y la hematuria dismórfica, que es característica de un origen glomerular. Los síntomas sistémicos como artralgias y fiebre de 3 días de evolución refuerzan la idea de un proceso inflamatorio generalizado. El perfil inmunológico es clave para el diagnóstico diferencial. La presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) negativos descarta lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes que comúnmente cursan con ANA positivos. Sin embargo, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) positivos con patrón perinuclear (p-ANCA) son un hallazgo crucial. El p-ANCA se asocia principalmente a la presencia de anticuerpos anti-mieloperoxidasa (anti-MPO) y es un marcador característico de las vasculitis asociadas a ANCA, especialmente la poliangeítis microscópica (MPA). La MPA es una vasculitis necrotizante de vasos pequeños que afecta capilares, vénulas y arteriolas, y la afectación renal en forma de glomerulonefritis necrotizante pauciinmune (con poca o ninguna evidencia de depósito de inmunocomplejos en la biopsia renal) es una de sus manifestaciones más frecuentes y graves, coincidiendo perfectamente con la presentación del paciente.

## BLOQUE 3 ESCLEROSIS SISTÉMICA, MIOPATÍAS INFLAMATORIAS Y SÍNDROMES AUTOINMUNES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La respuesta correcta es la A) Acortamiento del TTPA. En el síndrome antifosfolípido (SAF), paradójicamente, a pesar de asociarse a trombosis, el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) suele estar prolongado, NO acortado. Esto se debe a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que interfieren con las pruebas de coagulación *in vitro*, prolongando el tiempo de coagulación en el laboratorio. La paradoja reside en que estos anticuerpos, *in vivo*, promueven un estado protrombótico, pero *in vitro* interfieren con las reacciones de fosfolípidos necesarias para la correcta medición del TTPA. Es crucial recordar que el SAF es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos (anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína I y/o anticoagulante lúpico) asociado a eventos trombóticos (arteriales o venosos) o complicaciones obstétricas (abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia severa). La prolongación del TTPA, aunque no patognomónica, es una característica común en las pruebas de laboratorio en pacientes con SAF. La presencia del anticoagulante lúpico es la causa más común de prolongación del TTPA en el contexto del SAF.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: B**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El diagnóstico más probable en esta paciente es un Síndrome Antifosfolípido (SAF). Este se define por la presencia de criterios clínicos (trombosis vascular o morbilidad obstétrica) y de laboratorio (presencia de anticuerpos antifosfolípidos). La paciente cumple con ambos: presenta un antecedente de trombosis venosa profunda (criterio clínico de trombosis) y tres abortos previos (criterio clínico de morbilidad obstétrica). Además, los exámenes de laboratorio confirman la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas. La fisiopatología central del SAF es un estado de hipercoagulabilidad que predispone a eventos trombóticos tanto arteriales como venosos. Por lo tanto, el pilar del tratamiento y el manejo más urgente es la prevención de nuevos episodios de trombosis, que pueden ser potencialmente mortales (como un tromboembolismo pulmonar o un accidente cerebrovascular). Para la prevención secundaria (es decir, en pacientes que ya han sufrido un evento trombótico como esta paciente), el tratamiento de elección es la anticoagulación a largo plazo, generalmente con antagonistas de la vitamina K (como warfarina o acenocumarol) o, en casos seleccionados, con anticoagulantes orales directos. El objetivo es mantener al paciente en un rango terapéutico de anticoagulación para reducir significativamente el riesgo de recurrencia trombótica. La presencia de ANA y Factor Reumatoide positivos puede sugerir una enfermedad del tejido conectivo subyacente (como Lupus Eritematoso Sistémico, del cual el SAF puede ser secundario), pero no cambia el manejo inicial y prioritario, que es controlar el riesgo trombótico inmediato.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La paciente presenta un cuadro clínico muy sugerente de una enfermedad autoinmune sistémica, específicamente Lupus Eritematoso Sistémico (LES) con una alta probabilidad de coexistencia o presentación primaria de Síndrome Antifosfolípido (SAF). Los datos clave que apuntan a esto son: 1. **Antecedente de esplenectomía por trombocitopenia:** Sugiere una púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una condición autoinmune que frecuentemente se asocia con LES. 2. **Cuatro abortos y un cuadro de trombosis venosa profunda:** Esta combinación de pérdidas recurrentes de embarazo y eventos trombóticos es patognomónica del Síndrome Antifosfolípido (SAF), una trombofilia adquirida que puede presentarse de forma primaria o secundaria a otras enfermedades autoinmunes como el LES. 3. **Síntomas sistémicos actuales:** Artralgias generalizadas, astenia, abultamientos ganglionares y fiebre son manifestaciones inespecíficas pero comunes de enfermedades autoinmunes sistémicas. Considerando estos antecedentes, las pruebas de laboratorio de mayor utilidad para llegar al diagnóstico son los Anticuerpos Antinucleares (ANA) como cribado para el LES y otras enfermedades del tejido conectivo, y los Anticuerpos Anticardiolipina para confirmar el Síndrome Antifosfolípido, dada la fuerte sospecha clínica. El ANA es positivo en más del 95% de los pacientes con LES, lo que lo convierte en una excelente prueba de tamizaje. Los anticuerpos anticardiolipina son uno de los principales criterios de laboratorio para el diagnóstico del SAF.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: E**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La pregunta evalúa el conocimiento sobre las contraindicaciones de los anticonceptivos orales (ACO), específicamente los combinados (estrógeno y progestina), que son los que tienen la mayor cantidad de restricciones. La respuesta correcta es la paciente con antecedente de abortos a repetición. Un historial de abortos recurrentes no constituye, por sí mismo, una contraindicación para el uso de ACO. Las causas del aborto a repetición son variadas (genéticas, anatómicas, endocrinas, inmunológicas), pero ninguna de ellas se ve directamente agravada por el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales (supresión de la ovulación, espesamiento del moco cervical y alteración endometrial). De hecho, si una paciente con este antecedente desea posponer un nuevo embarazo mientras se completa su estudio, la anticoncepción hormonal es una opción válida y segura. Es crucial diferenciar el antecedente de abortos a repetición de una de sus posibles causas, como el Síndrome Antifosfolípido (SAF), que sí es una contraindicación absoluta para el uso de ACO combinados debido al altísimo riesgo trombótico. Sin embargo, la pregunta solo menciona el antecedente, no un diagnóstico causal específico que contraindique los ACO.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.11.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un síndrome de CREST clásico (Solo falta la calcinosis, pero tiene Raynaud, Esofagopatía, eSclerodactilia y Telangiectasias, más la Tirantez e la cara).

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: A**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.11.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 149). Evalúa el manejo clínico de Síndrome antifosfolípidos según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico**

1.11.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de túnel carpiano" (1.11.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: D**

**Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal**

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es d) Hipertensión pulmonar. Los pacientes con esclerodermia sistémica limitada, también conocida como síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias), tienen un riesgo significativamente elevado de desarrollar hipertensión arterial pulmonar (HAP). Esta complicación es una de las principales causas de morbimortalidad en este subgrupo de pacientes. La patogenia implica una vasculopatía proliferativa en las arteriolas pulmonares, que conduce a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. La hipertensión pulmonar en CREST se distingue a menudo de la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) que es más característica de la esclerodermia difusa. En el caso de CREST, la HAP puede ocurrir de forma aislada o con una enfermedad pulmonar intersticial leve. Es crucial la detección temprana mediante pruebas de detección como el ecocardiograma y la confirmación mediante cateterismo cardíaco derecho, dado que existen terapias específicas para la HAP que pueden mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. La vasculopatía que subyace al fenómeno de Raynaud, una característica central del CREST, también contribuye a la susceptibilidad a la hipertensión pulmonar, reflejando una disfunción endotelial sistémica. La presencia de anticuerpos anticentrómero, que son altamente específicos para el CREST, también se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar HAP.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: D**

**Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal**

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es d) Anticuerpos anticentrómero – Esclerodermia. Los anticuerpos anticentrómero (ACA) son un marcador inmunológico de gran relevancia en el diagnóstico y la clasificación de la esclerosis sistémica, también conocida como esclerodermia. Estos anticuerpos se dirigen específicamente contra las proteínas del centrómero, una región esencial de los cromosomas. Su presencia es particularmente característica de la forma cutánea limitada de la esclerosis sistémica, que históricamente se ha asociado con el síndrome CREST (Calcinosis, Fenómeno de Raynaud, Disfunción Esofágica, Esclerodactilia, Telangiectasias). La especificidad de los anticuerpos anticentrómero para la esclerosis sistémica limitada es muy alta, encontrándose en aproximadamente el 50-90% de los pacientes con esta presentación. Su detección no solo apoya el diagnóstico, sino que también puede ayudar a predecir un curso de la enfermedad diferente al de la esclerosis sistémica difusa (donde son más comunes los anticuerpos anti-topoisomerasa I o Scl-70). Aunque los pacientes con ACA generalmente tienen una menor incidencia de fibrosis pulmonar severa, mantienen un riesgo significativo de desarrollar hipertensión pulmonar, lo que subraya la importancia de un seguimiento clínico adecuado. Por lo tanto, la asociación entre anticuerpos anticentrómero y esclerodermia, especialmente la forma limitada, es una de las correlaciones más sólidas y reconocidas en el campo de la reumatología y las enfermedades autoinmunes, haciendo de esta la opción inequívocamente correcta.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: D**

**Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal**

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La paciente presenta un cuadro clínico de disnea progresiva y edema en las extremidades inferiores, que junto con la hipoxia en la gasometría arterial y la ausencia de afectación parenquimatosa en la radiografía de tórax, sugiere fuertemente una patología que afecta el sistema cardiovascular o la vasculatura pulmonar. La clave diagnóstica reside en el antecedente de Esclerosis Sistémica (ES) de 10 años de evolución, con la presencia de anticuerpos anticentrómero. Los anticuerpos anticentrómero son altamente específicos de la Esclerosis Sistémica Cutánea Limitada (lcSS), un subtipo de ES que tiene una marcada predisposición a desarrollar Hipertensión Pulmonar Arterial (HAP). La HAP en el contexto de la ES es una complicación grave donde las arterias pulmonares se estrechan, engrosan y se vuelven menos elásticas, aumentando la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones. Esto provoca una sobrecarga de trabajo para el ventrículo derecho del corazón, que eventualmente conduce a su hipertrofia y posterior fallo. Los síntomas de la paciente, como la disnea progresiva (debido a la incapacidad para aumentar el gasto cardíaco y la alteración de la relación ventilación/perfusión), la fatiga y el edema periférico (manifestación de la insuficiencia cardíaca derecha), son las características clásicas de la HAP e insuficiencia cardíaca derecha. La radiografía de tórax sin afectación parenquimatosa es un dato crucial, ya que ayuda a descartar otras complicaciones pulmonares de la ES como la enfermedad pulmonar intersticial, que sí mostraría cambios en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, la Hipertensión Pulmonar es la causa más probable del cuadro actual de esta paciente, dada su historia clínica y los hallazgos.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

**Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal**

1.05.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es el fenómeno de Raynaud porque es la manifestación clínica más frecuente y, a menudo, la más temprana en la esclerodermia sistémica, especialmente en su forma limitada. Este fenómeno se presenta en más del 95% de los pacientes y puede preceder al diagnóstico definitivo por años o incluso décadas. Consiste en episodios de vasoespasmo en las arteriolas de los dedos de manos y pies (y a veces nariz u orejas) en respuesta al frío o al estrés emocional, lo que provoca una secuencia de cambios de color característicos: palidez (isquemia), cianosis (desoxigenación) y rubor (reperfusión). La esclerodermia sistémica limitada (anteriormente conocida como síndrome de CREST) se caracteriza por un endurecimiento de la piel (esclerosis) que se limita a las zonas distales de las extremidades (manos, antebrazos) y la cara. A diferencia de la forma difusa, la afectación de órganos internos tiende a ser más tardía y menos agresiva, con la excepción de la hipertensión arterial pulmonar. Dado que el fenómeno de Raynaud es el sello distintivo y la manifestación inicial en la abrumadora mayoría de estos pacientes, es indiscutiblemente la respuesta más correcta y frecuente de la lista.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto**

1.11.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La debilidad proximal orienta a miopatía. La elevación de la CK y de los parámetros inflamatorios (PCR) orienta a polimiositis. La polimialgia reumática también puede tener una clínica similar e incluso elevar las CK, pero tiende a elevar mucho la VHS (la polimiositis también puede hacerlo) y, lo más importante, no tiene debilidad en el examen físico (aunque sí puede tener sensación de debilidad). La miopatía por cuerpos de inclusión también es una miopatía inflamatoria y puede tener una clínica similar, pero mucho más lenta (de años o varios meses) y suele afectar muslos y antebrazos con más frecuencia (afectación proximal y distal). Revisar semiología neurológica para las otras opciones.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

**Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto**

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la combinación de debilidad muscular proximal y simétrica, junto con manifestaciones cutáneas distintivas. Estas lesiones en la piel son fundamentales para el diagnóstico y a menudo preceden a la debilidad muscular. El **eritema en manto**, también conocido como "signo del chal" (del inglés, *shawl sign*), es una de las lesiones más características de la dermatomiositis. Consiste en un eritema violáceo o rojizo, plano o ligeramente sobreelevado, que afecta a los hombros, la parte superior de la espalda y el cuello, en un patrón de distribución que simula un chal. Con frecuencia, se extiende a la parte superior del pecho en forma de "V" (signo de la V). Esta lesión es una manifestación de la fotosensibilidad que presentan estos pacientes y refleja la inflamación subyacente de la piel en áreas expuestas al sol. Junto con el eritema en manto, otras lesiones cutáneas patognomónicas o muy características de la DM incluyen las pápulas de Gottron (pápulas violáceas sobre las articulaciones de los nudillos) y el eritema en heliotropo (eritema violáceo en los párpados superiores, a menudo con edema). La presencia de estas lesiones, en el contexto clínico adecuado, es altamente sugestiva del diagnóstico de dermatomiositis.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: E**

**Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto**

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por la inflamación y debilidad de los músculos esqueléticos, acompañada de manifestaciones cutáneas distintivas. El proceso patológico central implica el daño a las fibras musculares. La creatinfosfoquinasa (CPK o CK) es una enzima que se encuentra predominantemente en el citoplasma de las células musculares esqueléticas y cardíacas, así como en el cerebro. Es un biomarcador clave de daño muscular. Cuando las células musculares sufren daño o necrosis, como ocurre en la dermatomiositis debido a la inflamación autoinmune, la CPK se libera en grandes cantidades al torrente sanguíneo. Por esta razón, los niveles elevados de CPK sérica son el marcador bioquímico más sensible, frecuente y característico de la lesión muscular activa en pacientes con dermatomiositis y otras miopatías inflamatorias. La magnitud de la elevación de la CPK suele correlacionarse con la actividad de la enfermedad y la extensión del daño muscular, convirtiéndola en un parámetro esencial no solo para el diagnóstico sino también para monitorizar la respuesta al tratamiento. Aunque otras condiciones pueden elevar la CPK (como ejercicio intenso, traumatismos o infarto de miocardio), en el contexto clínico de debilidad muscular progresiva y hallazgos cutáneos típicos, una CPK elevada es altamente indicativa de una miopatía inflamatoria.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: C**

**Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto**

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por debilidad muscular proximal y erupciones cutáneas características. Una característica importante de la dermatomiositis es su asociación con neoplasias malignas, especialmente en adultos. Los anticuerpos anti-Jo-1 son anticuerpos anti-aminoacil tRNA sintetasa (ARS) y son los más comunes en el síndrome antisintetasa, que incluye dermatomiositis/polimiositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fenómeno de Raynaud y fiebre. Si bien no son *específicos* de la dermatomiositis asociada a cáncer, son el marcador inmunológico más característico de la dermatomiositis en general y, por lo tanto, la mejor respuesta entre las opciones dadas. En el contexto de una pregunta que menciona la asociación con cáncer, es importante recordar que la presencia de anticuerpos anti-Jo-1 debe alertar al clínico sobre la posibilidad de un síndrome antisintetasa y, por tanto, considerar la búsqueda de neoplasias. Es importante mencionar que en la evaluación de dermatomiositis en Chile, se debe seguir la guía clínica correspondiente (si existiera una guía ministerial específica, se citaría aquí). Sin embargo, dado que las guías chilenas suelen ser menos detalladas en inmunología específica, se recurre a la práctica clínica internacional basada en la evidencia.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: D**

**Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto**

1.11.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la D (Creatinkinasa (CK) y anticuerpos anti Jo-1) porque la dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal y hallazgos cutáneos típicos como el eritema en heliotropo (párpados superiores) y el signo de Gottron (eritema en hombros y región superior del tórax, como describe el caso). La creatinkinasa (CK) es una enzima muscular que se eleva en la dermatomiositis debido a la destrucción muscular (miopatía inflamatoria). Los anticuerpos anti-Jo-1 son un tipo de anticuerpo anti-ARNt sintetasa, fuertemente asociado con la dermatomiositis y el síndrome antisintetasa (que puede incluir miositis, enfermedad pulmonar intersticial, artritis, fiebre y fenómeno de Raynaud). La presencia de estos marcadores apoya fuertemente el diagnóstico de dermatomiositis. Si bien la guía clínica chilena de Artritis Reumatoide (MINSAL) no cubre específicamente la dermatomiositis, los principios generales de diagnóstico de enfermedades autoinmunes se aplican.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: A**

**Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal**

1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El fenómeno de Raynaud es una respuesta vascular exagerada al frío o al estrés emocional, que provoca un vasoespasmo de las arterias y arteriolas periféricas, principalmente en los dedos de las manos y los pies. Clínicamente, se manifiesta por una secuencia de cambios de coloración trifásica característica: palidez (fase isquémica), cianosis (fase de desoxigenación) y finalmente rubor (fase de reperfusión o hiperemia reactiva). Aunque puede ser primario (enfermedad de Raynaud), es más relevante clínicamente cuando es secundario a otra patología. La asociación entre el fenómeno de Raynaud y la esclerodermia (específicamente la Esclerosis Sistémica) es extremadamente fuerte y fundamental para el diagnóstico. Se considera el signo clínico más característico, estando presente en más del 90-95% de los pacientes, y a menudo es el síntoma de presentación, apareciendo meses o incluso años antes de otras manifestaciones como el engrosamiento cutáneo o el compromiso de órganos internos. La fisiopatología de la esclerodermia, que implica daño endotelial, disfunción vascular y fibrosis progresiva de la pared de los vasos, explica por qué el Raynaud en estos pacientes es particularmente severo y puede llevar a complicaciones graves como úlceras digitales isquémicas, cicatrices puntiformes (pitting scars) o incluso gangrena. Debido a esta altísima prevalencia y a su papel como síntoma centinela, la presencia de un fenómeno de Raynaud de inicio reciente en un adulto obliga a descartar una enfermedad del tejido conectivo subyacente, siendo la esclerodermia la principal sospecha. La capilaroscopia del lecho ungueal es una herramienta clave en esta diferenciación, ya que en la esclerodermia mostrará un patrón característico de "patrón esclerodérmico" (megacapilares, áreas avasculares, capilares ramificados), a diferencia del patrón normal que se observa en el Raynaud primario.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: D**

**Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)**

1.11.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base a una serie de criterios clínicos y de laboratorio, que no vale la pena aprenderse.

---

## BLOQUE 4 ESPONDILOARTRITIS SERONEGATIVAS Y ENFERMEDAD DE BEHÇET · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: E**

**Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La espondilitis anquilosante (EA o espondiloartritis anquilopoyética) es una enfermedad inflamatoria crónica que pertenece al grupo de las espondiloartropatías seronegativas. Se caracteriza principalmente por la inflamación de las articulaciones sacroilíacas y la columna vertebral, pero también puede afectar otras articulaciones y tener manifestaciones extraarticulares. La vasculitis de pequeños vasos, sin embargo, no es una manifestación típica ni reconocida de la espondilitis anquilosante. Las vasculitis de pequeños vasos son un grupo diverso de trastornos en los que la inflamación afecta los vasos sanguíneos de pequeño calibre, como arteriolas, capilares y vénulas, y suelen presentarse con síntomas cutáneos (púrpura palpable), renales (glomerulonefritis), pulmonares (hemorragia alveolar), neurológicos o gastrointestinales. La espondilitis anquilosante tiene mecanismos patogénicos distintos a los que subyacen a las vasculitis de pequeños vasos. Aunque ambas son enfermedades autoinmunes o inflamatorias, la patogenia de la EA está fuertemente asociada al HLA-B27 y se centra en la entesitis (inflamación de la inserción de tendones y ligamentos en el hueso) y la artritis de las articulaciones axiales. La presencia de vasculitis de pequeños vasos en un paciente con EA sería probablemente una coexistencia de dos enfermedades distintas o un diagnóstico alternativo, pero no una manifestación intrínseca de la espondilitis anquilosante. Por lo tanto, "Vasculitis de pequeños vasos" es la opción correcta como la manifestación que NO se asocia con la espondilitis anquilosante.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

**Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es **B (Pelviespondilopatía)**. Varias características del caso clínico apuntan a este diagnóstico. En primer lugar, el dolor lumbar de ritmo inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el ejercicio) es un sello distintivo de las pelviespondilopatías. La talalgia matinal y la molestia en el tendón de Aquiles sugieren entesitis, una manifestación común de estas enfermedades. Además, la dactilitis (dedo en salchicha), manifestada como el segundo ortejo rojo y doloroso, es altamente sugestiva de espondiloartritis. La respuesta parcial y transitoria a antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) también es consistente con el cuadro. En resumen, la combinación de dolor lumbar inflamatorio, entesitis y dactilitis en un hombre joven, deportista, hace que la pelviespondilopatía sea el diagnóstico más probable. Según la Guía Clínica AUGE de Artritis Reumatoide del MINSAL, aunque esta guía se centra en la artritis reumatoide, es importante considerar otras etiologías de artritis y dolor inflamatorio, como las pelviespondilopatías, en el diagnóstico diferencial. Los criterios de clasificación para espondiloartritis axial (ASAS) y periférica (ASAS) deben ser considerados.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico**

1.11.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago infeccioso y tumoral" (1.11.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

**Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico**

1.11.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago mecánico" (1.11.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

**Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico**

1.11.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una espondilitis anquilosante clásica tanto por el lumbago inflamatorio (mayor en la noche y en el reposo) como por la uveítis.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: C**

**Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente de 27 años presenta un cuadro clínico muy sugerente de Espondilitis Anquilosante (EA), una enfermedad inflamatoria crónica que forma parte del grupo de las Espondiloartropatías. Los elementos clave para este diagnóstico son: el dolor lumbar crónico de tipo inflamatorio (mayor en reposo, rigidez matinal), la presencia de artritis periférica (rodilla derecha), y especialmente los hallazgos radiográficos de sacroileítis bilateral y la calcificación/osificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior de la columna, que son signos distintivos de la enfermedad. El tratamiento de elección para la Espondilitis Anquilosante, particularmente en sus etapas iniciales o cuando no hay indicación de terapias biológicas, se basa en dos pilares fundamentales. Farmacológicamente, los Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) son la primera línea de tratamiento para controlar el dolor y la inflamación, mejorando la rigidez y la función espinal. Son eficaces en la mayoría de los pacientes y se utilizan de forma regular o a demanda. Paralelamente, la terapia no farmacológica, específicamente el ejercicio y la kinesioterapia, es crucial y debe iniciarse de forma temprana y mantenerse de por vida. El ejercicio regular ayuda a mantener la movilidad espinal, prevenir la progresión de la deformidad, fortalecer la musculatura y mejorar la postura, impactando significativamente en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, la combinación de AINEs y ejercicios constituye el abordaje terapéutico inicial más adecuado para esta patología.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la A (Iniciar AINEs e indicar ejercicios periódicos) porque el cuadro clínico del paciente (dolor lumbar insidioso que mejora con el ejercicio, rigidez matinal, sacroileítis bilateral y calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales) es altamente sugestivo de espondilitis anquilosante o una espondiloartritis axial no radiográfica (según la clasificación ASAS). El tratamiento inicial de la espondiloartritis axial, según la guía clínica del MINSAL para el manejo de la artritis reumatoide (que también se aplica, con matices, a las espondiloartritis), se basa en el uso de AINEs como primera línea para controlar el dolor y la inflamación. Adicionalmente, la terapia física y los ejercicios periódicos son fundamentales para mantener la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad. El objetivo es reducir la rigidez, mejorar la postura y fortalecer los músculos de la espalda.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: D**

**Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la D (Iniciar AINES e indicar ejercicios) porque el paciente presenta un cuadro clínico compatible con espondiloartritis axial no radiográfica (EspAax-nr) o, con mayor probabilidad dados los hallazgos radiológicos, con espondiloartritis axial radiográfica (EspAax-r), también conocida como espondilitis anquilosante. Los síntomas característicos incluyen lumbago inflamatorio (predominio nocturno, mejora con el movimiento y empeora con el reposo, rigidez matinal prolongada) y la radiografía confirma la sacroileítis y la calcificación de los ligamentos vertebrales longitudinales (sindesmófitos). El manejo inicial de la EspAax, según las guías internacionales y adaptado a la realidad chilena, se basa en el uso de AINEs para el control del dolor y la inflamación, junto con un programa de ejercicios para mantener la movilidad y la función. La guía de práctica clínica del MINSAL sobre artrosis (que si bien no es espondiloartritis, comparte principios en el manejo del dolor crónico) también enfatiza la importancia del ejercicio y la terapia física en el manejo del dolor lumbar.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: C**

**Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF**

1.08.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la C (Solicitar radiografía de columna lumbosacra). Este paciente presenta características sugestivas de espondiloartritis axial (EspA), específicamente espondilitis anquilosante. Los síntomas clave son: * **Dolor lumbar inflamatorio:** Inicio insidioso, menor de 45 años, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, y es peor por la noche (aunque este dato no está explícitamente mencionado, la rigidez matinal es una característica importante). * **Rigidez matinal prolongada:** Mayor de 30 minutos. * **Limitación de la movilidad de la columna:** Marcada dificultad para la flexión. Si bien el diagnóstico definitivo de espondiloartritis requiere la demostración de sacroileítis en radiografía o resonancia magnética (RM), la **radiografía es el examen de primera línea para evaluar la presencia de sacroileítis estructural en pacientes con alta sospecha clínica**. La RM se reserva para casos donde la radiografía es normal o dudosa, pero la sospecha clínica persiste, o para evaluar actividad inflamatoria aguda. Las guías clínicas chilenas (AUGE Espondiloartritis) enfatizan la importancia de una evaluación radiológica inicial para detectar sacroileítis y otras alteraciones estructurales en la columna. Aunque la RM es más sensible para detectar cambios inflamatorios tempranos, la radiografía es una herramienta accesible y útil para el diagnóstico inicial, especialmente en el contexto del EUNACOM y la realidad de la atención primaria. La clínica, en este caso, sugiere fuertemente la patología, justificando el examen.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

**Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF**

1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Columna dolorosa" (1.11.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: C**

**Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII**

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una artritis psoriática clásica (con los picotazos ungueales).

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

**Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII**

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta (C) describe la forma de presentación clínica más común de la artritis psoriásica (APs), que corresponde a una oligoartritis asimétrica. Este patrón, que afecta a menos de cinco articulaciones de manera no simétrica, representa aproximadamente el 50-70% de los casos al inicio de la enfermedad. Puede comprometer tanto articulaciones grandes (como rodillas o tobillos) como pequeñas (interfalángicas de manos y pies), a menudo de forma aditiva o migratoria, donde la inflamación parece "saltar" de una articulación a otra. Un hallazgo clínico característico y muy sugerente de la APs, mencionado en la opción, es la dactilitis o "dedo en salchicha". Corresponde a la inflamación de todo un dedo (mano o pie), incluyendo la articulación, la vaina tendinosa de los flexores y el tejido blando circundante. La presencia de dactilitis junto a una oligoartritis asimétrica es un cuadro clínico altamente específico para el diagnóstico de artritis psoriásica, diferenciándola de otras artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: D**

**Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII**

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **d) Psoriasis** debido a la descripción clásica de las lesiones ungueales. La presencia de "depresiones puntiformes, similares a picotazos" (conocidas como *pitting* ungueal) es una característica patognomónica de la psoriasis ungueal. Estas lesiones se producen por una alteración en la queratinización de las células de la matriz ungueal, lo que lleva a la formación de pequeñas depresiones en la superficie de la lámina ungueal. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar la piel, las articulaciones y las uñas. Aproximadamente el 50% de los pacientes con psoriasis cutánea presentan afectación ungueal, y hasta el 80% de los pacientes con artritis psoriásica tienen lesiones en las uñas. Aunque las lesiones ungueales pueden aparecer en ausencia de psoriasis cutánea, la edad de la paciente (32 años) es compatible con el inicio de la enfermedad. Otras manifestaciones de la psoriasis ungueal pueden incluir onicólisis (desprendimiento de la uña), hiperqueratosis subungueal, manchas de aceite (manchas amarillentas-parduscas) y hemorragias en astilla. Sin embargo, el *pitting* es el hallazgo más distintivo descrito en la pregunta.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII**

1.11.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una artriGs psoriática clásica, con dacGliGs (“dedos en salchicha”) y lesiones ungueales (“en picotazo de pájaro).

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento**

El caso clínico describe un paciente de 45 años que presenta un cuadro diarreico autolimitado seguido, aproximadamente 10 días después, por un cuadro caracterizado por: dolor lumbar, artritis (rodillas y manos), ojo rojo profundo y disuria. Esta secuencia y presentación clínica son altamente sugestivas de un Síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva. El síndrome de Reiter clásico se define como una tríada de artritis, uretritis (manifestada aquí como disuria) y conjuntivitis (manifestada como ojo rojo). En este caso, la diarrea previa sugiere una infección entérica como desencadenante, lo cual es común en la artritis reactiva. La artritis reactiva se caracteriza por ser una oligoartritis asimétrica, afectando predominantemente grandes articulaciones de extremidades inferiores (rodillas, tobillos), aunque también puede afectar pequeñas articulaciones como las de las manos. El dolor lumbar puede ser reflejo de sacroileitis, otra manifestación común en la artritis reactiva.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento**

El síndrome de Reiter, ahora conocido como Artritis Reactiva, es una condición inflamatoria que típicamente se presenta después de una infección, comúnmente gastrointestinal o genitourinaria. La tríada clásica (aunque no siempre completa) incluye artritis (generalmente asimétrica, oligoarticular, afectando principalmente miembros inferiores), uretritis (que se manifiesta como disuria dolorosa) y conjuntivitis (el "ojo rojo"). En este caso, el paciente presenta dolor lumbar (una forma de espondiloartropatía), artritis de rodillas y manos, ojo rojo y disuria dolorosa, lo cual se alinea perfectamente con el diagnóstico de Artritis Reactiva. La aparición reciente de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tratada con doxiciclina es un desencadenante típico para esta condición, especialmente si la ETS fue una uretritis causada por Chlamydia trachomatis o si hubo una infección gastrointestinal concurrente. La presentación insidiosa y el empeoramiento con el reposo del dolor lumbar sugieren un componente inflamatorio, como en las espondiloartropatías, de las cuales la artritis reactiva es un miembro importante. La afectación de las articulaciones periféricas (rodillas y manos) junto con la uretritis y la conjuntivitis completan el cuadro diagnóstico. Si bien la doxiciclina es un tratamiento, no previene el desarrollo de la artritis reactiva en sí, que es una respuesta inmunológica al patógeno inicial.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

1.05.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis**

El desarrollo de una pápula eritematosa o pústula estéril entre las 24 y 48 horas posteriores a una microagresión traumática con aguja estéril en la piel del antebrazo se denomina Fenómeno de Patergia. Es un hallazgo semiológico característico de la Enfermedad de Behçet y traduce hiperreactividad del sistema inmune innato y neutrofílico.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

1.05.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis**

En la Enfermedad de Behçet las aftas bucales están presentes en el 100% de los casos y curan espontáneamente en 7-14 días sin dejar secuelas cicatriciales. En contraste, las aftas genitales (localizadas típicamente en escroto o vulva) son más profundas, sumamente dolorosas y curan dejando una cicatriz blanquecina o atrófica permanente que permite documentar retrospectivamente su presencia.

---

## BLOQUE 5 VASCULITIS SISTÉMICAS, REUMATOLOGÍA DE PARTES BLANDAS Y METABOLISMO ÓSEO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** Cervicalgia

1.11.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cervicalgia" (1.11.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Epicondilalgia, epitroclealgias** 1.11.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epicondilalgia, epitroclealgias" (1.11.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A** **Hombro doloroso** 1.11.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hombro doloroso" (1.11.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A** **Tendonitis y bursitis** 1.11.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tendonitis y bursitis" (1.11.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: C**

**Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu**

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es Arteritis de la Temporal (también conocida como Arteritis de células gigantes). Los síntomas presentados por el paciente son altamente sugestivos de esta condición. La cefalea de reciente inicio en un paciente de edad avanzada (mayor de 50 años), acompañada de astenia, claudicación mandibular (dolor al masticar) y dolor/cansancio en la musculatura proximal (al peinarse, levantar los brazos) son manifestaciones clásicas de la arteritis de la temporal. La claudicación mandibular es un hallazgo bastante específico. Estos síntomas se deben a la inflamación de las arterias craneales, particularmente la arteria temporal. Si bien no contamos con una guía clínica específica del MINSAL para la arteritis de la temporal, el manejo se basa en las guías internacionales y la experiencia clínica. El diagnóstico se confirma con una biopsia de la arteria temporal y se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: D**

**Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu**

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como arteritis temporal, es una vasculitis sistémica de grandes y medianas arterias, que afecta predominantemente a personas mayores de 50 años. La presentación clínica típica incluye síntomas constitucionales como astenia, debilidad (particularmente en las extremidades superiores de predominio proximal), fiebre ocasional y cefalea. La claudicación mandibular es un síntoma patognomónico de la ACG debido a la isquemia de los músculos masticatorios por afectación de las arterias faciales. La elevación marcada de la Velocidad de Sedimentación Globular (VHS) es un marcador inflamatorio característico de esta patología, a menudo acompañado de anemia de enfermedad crónica. La combinación de síntomas como astenia, debilidad proximal, claudicación mandibular, cefalea, fiebre ocasional, anemia y VHS marcadamente elevada en una paciente de 67 años apunta fuertemente hacia el diagnóstico de Arteritis de Células Gigantes. Otros hallazgos, como la posible afectación de la arteria oftálmica, que puede llevar a la pérdida de visión (aunque no se menciona explícitamente en el caso, es una complicación grave a considerar), refuerzan esta sospecha. El diagnóstico se confirma mediante biopsia de arteria temporal que muestra inflamación de la pared arterial con infiltrado de células gigantes y células mononucleares, aunque en ocasiones la biopsia puede ser negativa si la inflamación es segmentaria.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: E**

**Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu**

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pregunta describe un cuadro clínico altamente sugerente de Arteritis de Células Gigantes (ACG), también conocida como Arteritis Temporal, que con frecuencia se asocia a la Polimialgia Reumática (PMR). Un paciente de 65 años con astenia y debilidad muscular proximal (brazos, muslos) es un síntoma cardinal de la PMR. La presencia de cefalea frecuente y, crucialmente, dolor al masticar por mucho tiempo (claudicación mandibular), son síntomas altamente específicos de la ACG, indicando isquemia de los músculos de la masticación debido a la inflamación arterial. El hallazgo de una velocidad de sedimentación globular (VHS) extremadamente elevada (97 mm/h) y anemia normocítica normocrómica (anemia de enfermedad crónica) refuerza la sospecha de un proceso inflamatorio sistémico severo. La Arteritis de Células Gigantes es una emergencia médica debido al riesgo inminente de ceguera irreversible si no se trata de forma urgente. Por lo tanto, la conducta más adecuada es iniciar tratamiento de inmediato con corticoides a dosis altas (prednisona 1mg/Kg) para prevenir estas complicaciones, y simultáneamente solicitar una biopsia de arteria temporal, que es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico. El tratamiento no debe esperar la confirmación histológica.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu**

1.09.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomatosa crónica que afecta predominantemente a la aorta y sus principales ramas, así como a las arterias pulmonares. Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación progresiva de la pared arterial que puede conducir a estenosis, oclusión, dilatación o formación de aneurismas, lo que resulta en una amplia gama de manifestaciones clínicas debido a la isquemia de los órganos afectados. La opción a) "Glomerulonefritis" es la respuesta correcta porque la arteritis de Takayasu *no* se manifiesta típicamente con glomerulonefritis primaria como parte de su patogenia directa. La glomerulonefritis es una inflamación de los glomérulos renales, que es una característica distintiva de otras vasculitis, especialmente las de vasos pequeños como la granulomatosis con poliangitis (GPA), la poliangitis microscópica (PAM), o las vasculitis por complejos inmunes. Aunque la arteritis de Takayasu puede afectar las arterias renales, causando estenosis y consecuente hipertensión renovascular, y esta hipertensión prolongada puede eventualmente llevar a daño renal secundario (nefropatía hipertensiva), no se produce una inflamación directa de los glomérulos como parte de la enfermedad. La distinción es crucial para diferenciar la arteritis de Takayasu de otras formas de vasculitis que sí tienen afectación glomerular como una característica central.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

**Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu**

1.11.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una arteritis de la temporal o de células gigantes clásica.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)**

1.09.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la A. La vasculitis de Churg-Strauss (ahora conocida como granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, GEPA) es una vasculitis sistémica que se caracteriza por asma (frecuentemente de inicio tardío y difícil manejo), eosinofilia, manifestaciones alérgicas (rinitis, pólipos nasales), y vasculitis que afecta múltiples órganos. El compromiso renal, específicamente la glomerulonefritis, es una manifestación importante, aunque no tan frecuente como en otras vasculitis ANCA asociadas (como la granulomatosis con poliangeítis - GPA o granulomatosis de Wegener, y la poliangeítis microscópica - PAM). La presencia de ANCA (generalmente p-ANCA, anti-MPO) se encuentra en una proporción moderada de los casos (alrededor del 40-60%). La secuencia típica es la aparición de asma y manifestaciones alérgicas, seguida por eosinofilia y, finalmente, vasculitis. Aunque no existe una guía clínica chilena específica del MINSAL para GEPA, el manejo se basa en las guías internacionales y el conocimiento de la enfermedad.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

**Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)**

1.09.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

El diagnóstico de sospecha es Granulomatosis con Poliangeítis (GPA), anteriormente conocida como Granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta predominantemente a vasos de pequeño y mediano calibre. El cuadro clínico del paciente es altamente característico y se ajusta a la tríada clásica de esta enfermedad: compromiso de la vía aérea superior, compromiso de la vía aérea inferior (pulmones) y glomerulonefritis. El paciente presenta rinosinusitis crónica y epistaxis, que son manifestaciones directas de la inflamación granulomatosa y la vasculitis necrotizante en la vía aérea superior. Este compromiso puede ser muy destructivo, llegando a provocar perforación del tabique nasal o la deformidad en "silla de montar". El deterioro del estado general y la fiebre son síntomas constitucionales comunes en las vasculitis sistémicas activas. Finalmente, la aparición de hematuria y oliguria indica un compromiso renal agudo en forma de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una de las complicaciones más graves y definitorias de la GPA. El hallazgo de laboratorio es clave y prácticamente confirma la sospecha. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) con patrón citoplasmático (c-ANCA) son altamente específicos para la GPA. Estos anticuerpos están dirigidos contra la enzima proteinasa 3 (PR3), y su presencia, en el contexto clínico adecuado, tiene un valor predictivo positivo superior al 95% para el diagnóstico de esta enfermedad.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: D**

**Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)**

1.09.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La alternativa correcta es la D: Rinosinusitis de difícil manejo, asociada a glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar. La granulomatosis con poliangeítis (GPA), antiguamente conocida como granulomatosis de Wegener, es una vasculitis sistémica necrotizante que afecta principalmente a los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. Se caracteriza por la tríada clásica de: * **Afectación de la vía aérea superior:** Rinosinusitis crónica necrotizante, con obstrucción nasal, secreción purulenta, úlceras nasales y/o destrucción del cartílago nasal (nariz en silla de montar). Esta rinosinusitis suele ser muy resistente al tratamiento convencional. * **Afectación pulmonar:** Infiltrados pulmonares nodulares, cavitarios o no, que pueden causar tos, disnea, hemoptisis o ser asintomáticos. * **Afectación renal:** Glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede llevar a insuficiencia renal terminal si no se trata. La GPA es una enfermedad poco común, pero importante de reconocer debido a su potencial gravedad y necesidad de tratamiento inmunosupresor precoz. Si bien la tríada completa no siempre está presente al inicio, la combinación de rinosinusitis resistente al tratamiento con afectación renal y/o pulmonar debe generar una alta sospecha clínica. El diagnóstico se confirma con biopsia de tejido afectado (nariz, pulmón o riñón) y/o la presencia de anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA), típicamente con patrón c-ANCA (dirigido contra la proteinasa 3 o PR3). Si bien no hay una guía clínica específica del MINSAL para el manejo de la GPA, el diagnóstico precoz y el inicio de inmunosupresión son cruciales para prevenir el daño orgánico irreversible. Las guías internacionales (p.ej., las de la Sociedad Europea de Reumatología, EULAR) son la base para el tratamiento en Chile.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: E**

**Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)**

1.09.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La **Poliangeítis Microscópica (PAM)** es la alternativa correcta debido a la combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio presentados en el caso: * **Fiebre y Artralgias:** Sugieren un proceso inflamatorio sistémico. * **Hematuria y Edema de Extremidades Inferiores:** Indican afectación renal, muy probablemente una glomerulonefritis. El edema es consecuencia de la pérdida de proteínas por el riñón dañado y la retención de líquidos debido a la insuficiencia renal. * **Anuria y Elevación de Creatinina:** Señalan una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva. * **ANCA Perinuclear (p-ANCA) a Títulos Elevados:** Son altamente sugestivos de PAM, aunque también pueden estar presentes en otras vasculitis ANCA asociadas (ej. Granulomatosis con Poliangeítis (GPA)). En resumen, la PAM se presenta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a p-ANCA positivos, lo que concuerda con el caso presentado. No hay una guía clínica chilena específica del MINSAL para PAM. El manejo de esta patología se basa en guías internacionales, adaptadas a la realidad local. El enfoque general incluye el uso de inmunosupresores (corticoides, ciclofosfamida, rituximab) y, en ocasiones, plasmaféresis.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: D**

**Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS**

1.09.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción D es la correcta porque el rasgo fundamental y cardinal de la fibromialgia es el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, acompañado de una hipersensibilidad a la presión en múltiples puntos específicos del cuerpo. Este fenómeno se conoce como alodinia (percepción de dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como la presión moderada) e hiperalgesia (una respuesta de dolor exagerada a un estímulo doloroso). La exploración física, históricamente basada en los "puntos dolorosos" o *tender points* de los criterios del Colegio Americano de Reumatología (ACR) de 1990, demuestra precisamente esta característica: la palpación digital con una fuerza aproximada de 4 kg genera una respuesta dolorosa en el paciente que no se observa en personas sanas. La fisiopatología de la fibromialgia se centra en un trastorno de la modulación del dolor, conocido como "sensibilización central". En este estado, el sistema nervioso central se encuentra en un estado de hiperexcitabilidad persistente, amplificando las señales de dolor. Por lo tanto, el "dolor a la presión de las masas musculares" no se debe a una inflamación o daño en el músculo en sí, sino a una disfunción en el procesamiento central de los estímulos sensitivos. Aunque los criterios diagnósticos más recientes (ACR 2010/2016) han evolucionado para incluir un índice de dolor generalizado y una escala de gravedad de síntomas (fatiga, sueño no reparador, problemas cognitivos), la presencia de dolor difuso y sensibilidad a la palpación sigue siendo la piedra angular del diagnóstico clínico.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: D**

**Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS**

1.09.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La alternativa correcta es Trastorno por somatización porque el paciente presenta múltiples síntomas físicos (molestias faríngeas fluctuantes, globus, cefalea tensional, fibromialgia) sin una causa orgánica demostrable, y además tiene antecedentes de síndrome de intestino irritable, lo cual es común en pacientes con trastornos somatomorfos. El globus faríngeo, la sensación de "pelota en la garganta", es un síntoma típico de somatización, especialmente cuando no hay hallazgos al examen físico. La guía GES sobre depresión, aunque menciona síntomas somáticos en la depresión, no los prioriza en el diagnóstico diferencial del globus. En Chile, estos trastornos son frecuentemente subdiagnosticados, lo que resalta la importancia de considerarlos en el EUNACOM. Los criterios diagnósticos del trastorno por somatización (DSM-5) incluyen la presencia de síntomas somáticos persistentes que causan malestar significativo o alteración en el funcionamiento, así como pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con estos síntomas.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: B**

**Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS**

1.11.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: D**

**Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica**

1.09.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El diagnóstico de osteoporosis secundaria es el más probable debido a la confluencia de tres datos clave en el caso: la edad de la paciente, el valor del T-score y, fundamentalmente, el valor del Z-score. Primero, la paciente tiene 40 años, una edad en la que se considera premenopáusica. La osteoporosis en mujeres premenopáusicas es infrecuente y siempre debe hacer sospechar una causa subyacente. Segundo, su T-score de -2,6 cumple el criterio densitométrico de la OMS para osteoporosis (T-score ≤ -2,5), confirmando que la paciente tiene una densidad mineral ósea patológicamente baja. El dato más decisivo es el Z-score de -2,0. El Z-score compara la densidad mineral ósea de la paciente con la de otras personas de su misma edad, sexo y etnia. Un Z-score de -2,0 o inferior se considera "baja masa ósea para la edad" y es un fuerte indicador de que existe un factor secundario que está causando la pérdida ósea acelerada. A diferencia del T-score, que compara con el pico de masa ósea de un adulto joven sano (30 años), el Z-score es la herramienta fundamental para evaluar la salud ósea en niños, adolescentes y adultos jóvenes premenopáusicos. En resumen, una mujer de 40 años con osteoporosis densitométrica (T-score ≤ -2,5) y un Z-score significativamente bajo (≤ -2,0) tiene, por definición, una alta probabilidad de padecer osteoporosis secundaria. El siguiente paso en su manejo clínico sería iniciar un estudio etiológico exhaustivo para identificar la causa, que podría incluir patologías endocrinas (hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing), uso de fármacos (corticoides), enfermedades de malabsorción (celiaquía), enfermedades reumatológicas inflamatorias crónicas, entre otras.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: D**

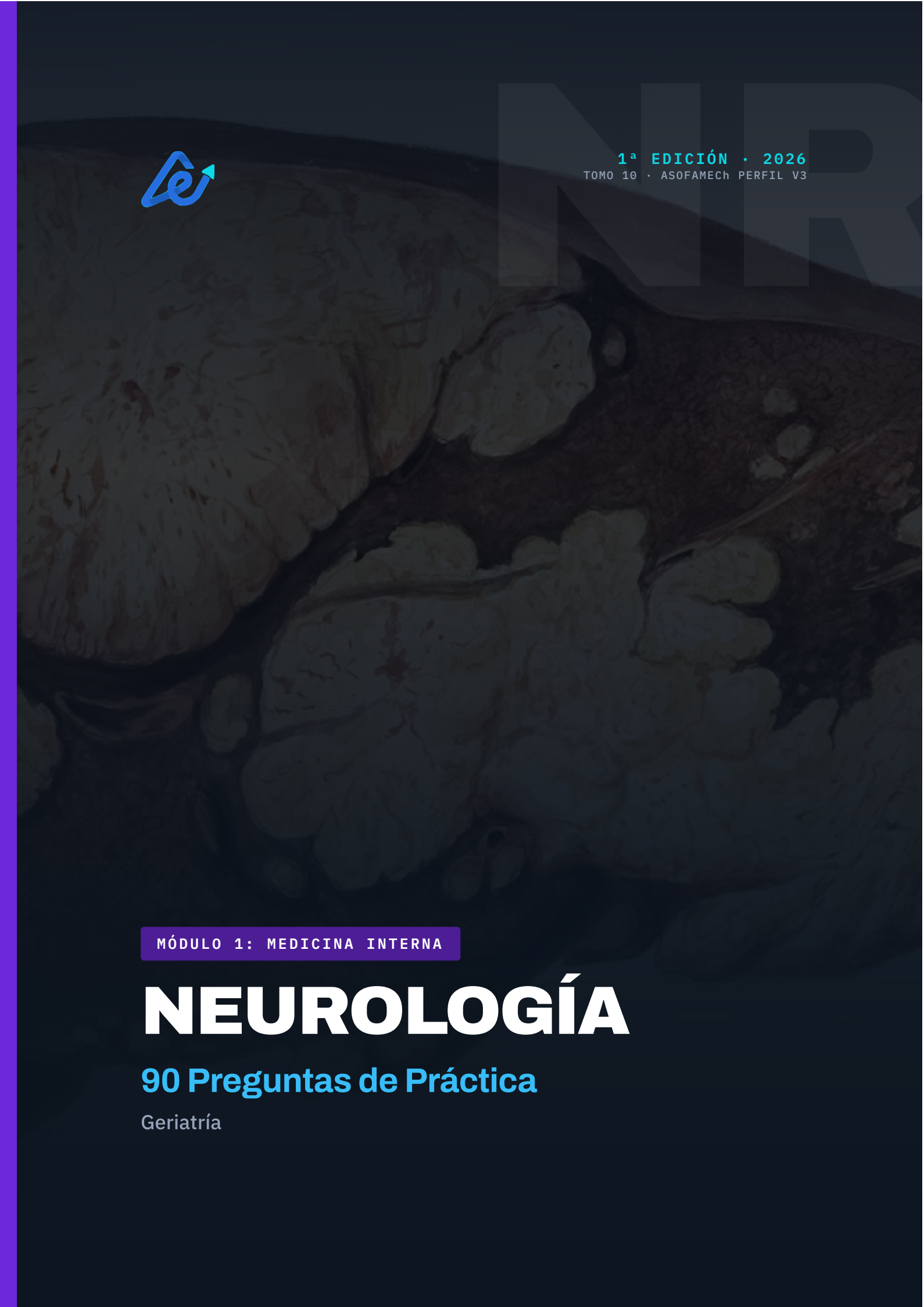
**Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica**

1.11.1.017

Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería ha- ber distractores correctos.



1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 10 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA

# NEUROLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Geriatría

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Neurología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 10 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES** | | | | | |
| 1.10.1.003 | Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.001 | Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5) |
| 1.10.2.002 | Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9, Q10 | Tomo 10 · 10.2 (Pág. 9) |
| 1.10.2.003 | Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15 | Tomo 10 · 10.3 (Pág. 11) |
| 1.10.2.004 | Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15) |
| 1.10.2.005 | Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 10 · 10.5 (Pág. 19) |
| 1.10.2.007 | Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 | Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5) |
| 1.10.2.008 | Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q17 | Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15) |
| 1.10.2.009 | Hipertensión endocraneana | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.021 | Traumatismo encefalocraneano grave | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q2 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA** | | | | | |
| 1.10.1.001 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 1.10.1.007 | Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33 | Tomo 10 · 10.8 (Pág. 30) |
| 1.10.1.012 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: | GES | Q23 | Tomo 10 · 10.6 (Pág. 24) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tensional | **Realizar** | | | |
| 1.10.1.013 | Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 10 · 10.7 (Pág. 28) |
| 1.10.1.018 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q24 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.019 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q25 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.021 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q26 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.022 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q27 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.023 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q28 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.024 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.010 | Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q34 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.012 | Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q32 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.014 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q30 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.015 | Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q21 | Tomo 10 · 10.10 (Pág. 38) |
| 1.10.2.016 | urémico, etc) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.017 | con meningitis purulenta o bacteriana | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.018 | Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 10 · 10.9 (Pág. 34) |
| 1.10.2.019 | Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q36 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS** | | | | | |
| 1.10.1.004 | Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 10 · C.3 (Pág. 10) |
| 1.10.1.005 | Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53 | Tomo 10 · 10.14 (Pág. 51) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1.006 | Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q46, Q47 | Tomo 10 · 10.11 (Pág. 43) |
| 1.10.1.026 | Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q48, Q49, Q50 | Tomo 10 · 10.13 (Pág. 49) |
| 1.10.1.027 | Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q45 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.028 | Tumores de región sellar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q38 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.029 | Tumores primarios y metastásicos SNC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.011 | Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q51 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.020 | Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q54 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO** | | | | | |
| 1.10.1.008 | Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68 | Tomo 10 · 10.18 (Pág. 68) |
| 1.10.1.009 | Herpes zoster | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q55 | Tomo 10 · C.5 (Pág. 14) |
| 1.10.1.010 | Lumbago mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q56 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.011 | Lumbociáticas y cervicobraquialgias. | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q57 | Tomo 10 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.10.1.014 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q69 | Tomo 10 · C.7 (Pág. 18) |
| 1.10.1.015 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 10 · C.11 (Pág. 26) |
| 1.10.1.016 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Realizar** | GES | Q71 | Tomo 10 · 10.19 (Pág. 72) |
| 1.10.1.017 | Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc... | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q58 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.020 | Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 10 · 10.17 (Pág. 64) |
| 1.10.1.025 | Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 10 · 10.20 (Pág. 74) |
| 1.10.2.013 | Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 10 · 10.16 (Pág. 60) |
| **BLOQUE 5: GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS** | | | | | |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07.1.001 | Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial / Derivación** · Seg: **Urgencia traumatológica / Ortogeriatría** | GES | Q85, Q86, Q87 | Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85) |
| 1.07.1.008 | Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio** | GES | Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 10 · 10.22 (Pág. 83) |
| 1.07.2.005 | Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Hospitalario / Ambulatorio** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 10 · 10.21 (Pág. 79) |
| 1.07.3.007 | Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio** | GES | Q88, Q89, Q90 | Tomo 10 · 10.24 (Pág. 87) |
| 1.10.1.002 | Compromiso de conciencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.006 | Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 11 · 11.12 (Pág. 49) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Neurología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07.1.001 | Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial / Derivación** · Seg: **Urgencia traumatológica / Ortogeriatría** | GES | Q85, Q86, Q87 | Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85) |
| 1.07.1.008 | Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio** | GES | Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 10 · 10.22 (Pág. 83) |
| 1.07.2.005 | Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Hospitalario / Ambulatorio** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80 | Tomo 10 · 10.21 (Pág. 79) |
| 1.07.3.007 | Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Control ambulatorio** | GES | Q88, Q89, Q90 | Tomo 10 · 10.24 (Pág. 87) |
| 1.10.1.001 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q22 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 1.10.1.002 | Compromiso de conciencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.003 | Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.004 | Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 10 · C.3 (Pág. 10) |
| 1.10.1.005 | Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53 | Tomo 10 · 10.14 (Pág. 51) |
| 1.10.1.006 | Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q46, Q47 | Tomo 10 · 10.11 (Pág. 43) |
| 1.10.1.007 | Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33 | Tomo 10 · 10.8 (Pág. 30) |
| 1.10.1.008 | Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68 | Tomo 10 · 10.18 (Pág. 68) |
| 1.10.1.009 | Herpes zoster | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q55 | Tomo 10 · C.5 (Pág. 14) |
| 1.10.1.010 | Lumbago mecánico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q56 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.011 | Lumbociáticas y cervicobraquialgias. | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q57 | Tomo 10 · C.6 (Pág. 16) |
| 1.10.1.012 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: | GES | Q23 | Tomo 10 · 10.6 (Pág. 24) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tensional | **Realizar** | | | |
| 1.10.1.013 | Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 10 · 10.7 (Pág. 28) |
| 1.10.1.014 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q69 | Tomo 10 · C.7 (Pág. 18) |
| 1.10.1.015 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 10 · C.11 (Pág. 26) |
| 1.10.1.016 | Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Realizar** | GES | Q71 | Tomo 10 · 10.19 (Pág. 72) |
| 1.10.1.017 | Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc... | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q58 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.018 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q24 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.019 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q25 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.020 | Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 10 · 10.17 (Pág. 64) |
| 1.10.1.021 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q26 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.022 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q27 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.023 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q28 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.024 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.025 | Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 10 · 10.20 (Pág. 74) |
| 1.10.1.026 | Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q48, Q49, Q50 | Tomo 10 · 10.13 (Pág. 49) |
| 1.10.1.027 | Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q45 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.028 | Tumores de región sellar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q38 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.1.029 | Tumores primarios y metastásicos SNC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.001 | Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2.002 | Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9, Q10 | Tomo 10 · 10.2 (Pág. 9) |
| 1.10.2.003 | Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15 | Tomo 10 · 10.3 (Pág. 11) |
| 1.10.2.004 | Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15) |
| 1.10.2.005 | Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 10 · 10.5 (Pág. 19) |
| 1.10.2.006 | Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 11 · 11.12 (Pág. 49) |
| 1.10.2.007 | Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 | Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5) |
| 1.10.2.008 | Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q17 | Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15) |
| 1.10.2.009 | Hipertensión endocraneana | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.010 | Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q34 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.011 | Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q51 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.012 | Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q32 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.013 | Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 10 · 10.16 (Pág. 60) |
| 1.10.2.014 | Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q30 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.015 | Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q21 | Tomo 10 · 10.10 (Pág. 38) |
| 1.10.2.016 | urémico, etc) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.017 | con meningitis purulenta o bacteriana | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2.018 | **Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 10 · 10.9 (Pág. 34) |
| 1.10.2.019 | **Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q36 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.020 | **Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve** | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q54 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |
| 1.10.2.021 | **Traumatismo encefalocraneano grave** | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q2 | Tomo 10 · Neurología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

PREGUNTA 1 — 1.10.2.009

**1. [URGENCIA: Hipertensión endocraneana · 1.10.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hipertensión endocraneana. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 2 — 1.10.2.021

**2. Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hematoma subdural derecho
B) Hematoma epidural derecho
C) Hemorragia subaracnoidea
D) Contusión encefálica frontal
E) Contusión encefálica temporal

PREGUNTA 3 — 1.10.2.001

**3. Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
B) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
C) Realizar endarterectomía derecha
D) Realizar endarterectomía bilateral
E) Solicitar angiografía carotídea

PREGUNTA 4 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

**4. Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
B) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
C) Realizar endarterectomía derecha
D) Realizar endarterectomía bilateral
E) Solicitar angiografía carotídea

PREGUNTA 5 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

**5. Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético presenta de forma súbita una hemiparesia derecha, asociada a afasia, de 30 minutos de duración. Se solicita TAC de cerebro que descarta hemorragias. Es manejado adecuadamente, con medidas de neuroprotección y afortunadamente, los síntomas inician una recuperación espontánea antes de comenzar el protocolo de trombolisis. Al segundo día está en excelentes condiciones, sin déficit neurológico ni otras alteraciones del examen físico. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar TAC de cerebro control
B) Solicitar electroencefalograma
C) Solicitar Holter de arritmias, ecocardiograma y eco-doppler carotideo
D) Iniciar aspirina
E) Iniciar anticoagulación oral a permanencia

PREGUNTA 6 — 1.10.2.001, 1.10.2.007

**6. Un paciente de 60 años, portador de una ACxFA tratada con atenolol y anticoagulación oral, consulta por hemiparesia izquierda, de inicio súbito hace 1 hora, asociada a hemihipoestesia ipsilateral. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
B) Solicitar electroencefalograma
C) Iniciar anticoagulación con heparina
D) Realizar trombolisis endovenosa
E) Solicitar angiografía carotidea

PREGUNTA 7 1.10.2.001, 1.10.2.007

**7. Ingresa a SU hombre de 72 años, HTA, DM2, dislipidemia, con 1 hora de evolución de afasia asociada a hemiparesia derecha. Se solicita TAC de cerebro que no muestra alteraciones. Su conducta siguiente sería:**

A) Inicio de AAS asociado a Acenocumarol (Neosintrom) e ingreso a intermedio.
B) Inicio de AAS 250 mg al día, heparina estandar por BIC e ingreso a UCI.
C) Inicio de trombolisis por SK asociado a heparina no fraccionada.
D) Dejar en evolución espontánea, se encuentra fuera de alcance terapéutico.
E) Inicio de trombolisis con tPA.

PREGUNTA 8 1.10.2.007

**8. Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. La conducta más adecuada es:**

A) Anticoagular con heparina
B) Administrar antiagregantes plaquetarios
C) Solicitar resonancia magnética nuclear
D) Realizar embolectomía
E) Realizar trombólisis

PREGUNTA 9 1.10.2.002

**9. Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:**

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

PREGUNTA 10 1.10.2.002

**10. Un paciente de 46 años, portador de una ACxFA crónica, en tratamiento con aspirina, presenta bruscamente imposibilidad para hablar y entender el lenguaje, asociado a hemiparesia derecha, de 30 minutos de duración, que ceden espontáneamente. Al examen físico está completamente normal, excepto por el pulso irregular a 80x'. La conducta más adecuada es:**

A) Enviar a domicilio, indicando anticoagulación con cumarínicos
B) Administrar heparina de bajo peso molecular y enviar a domicilio, con nuevas dosis subcutáneas, cada 12 horas
C) Solicitar TAC de cerebro y mantener aspirina
D) Enviar a domicilio, indicando control ambulatorio con el neurólogo
E) Hospitalizar, iniciar anticoagulación con heparina, solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro e iniciar medidas de neuroprotección

PREGUNTA 11 1.10.1.003

**11. Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de cerebro: colección hipodensa crónicamente organizada entre el córtex y el hueso craneal, sin efecto de masa severo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tumor cerebral primario
B) Metástasis cerebrales
C) Hematoma subdural crónico
D) Hidrocefalia normotensiva
E) Enfermedad de Alzheimer

PREGUNTA 12 1.10.2.003

**12. Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo mirada conjugada hacia derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguido de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en zona lateral de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Crisis convulsiva primariamente generalizada
B) Crisis focal secundariamente generalizado
C) Síncope vasovagal
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno facticio

PREGUNTA 13 1.10.2.003

**13. Un niño de 4 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre, asociado a rigidez de nuca en el examen físico. Se decide realizar punción lumbar, luego de descartar la presencia de hipertensión endocraneana con un TAC de cerebro, y se obtiene un líquido cefalorraquídeo claro, con 60 células por mm3, con 99% de mononucleares (linfocitos), proteínas: 50 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. El diagnóstico más probable es:**

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis bacteriana
C) Meningitis herpética
D) Meningitis viral
E) Sano

PREGUNTA 14 1.10.2.003

**14. Paciente de 45 años, diabético mal controlado, consulta por fiebre, tos productiva, disnea de reposo y finalmente compromiso de conciencia. Al examen se aprecia paciente en malas condiciones generales, con pulso: 140 lpm, regular, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 38 rpm, Glasgow: 10. En el examen segmentario destacan crépitos en base derecha y campo pulmonar izquierdo. Se inicia resucitación con suro fisiológico y oxígenos, logrando saturación arterial de 88% a FiO2: 50% y presión arterial: 100/58 mmHg. El tratamiento antibiótico para este paciente debe ser:**

A) Ceftriaxona + Amicacina
B) Ceftriaxona + Vancomicina
C) Cefotaximo + Ampicilina
D) Ceftriaxona + Claritromicina
E) Cefotaximo + Metronidazol

PREGUNTA 15 1.10.2.003

**15. Mujer de 64 años, ingresa por un accidente de tránsito. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes destaca Crea:3,9 y BUN:80. Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera, con buen resultado. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al 3er día reinicia diuresis, cercanas a 1.000cc/día, sin embargo persiste con crea: 3,5. El sodio urinario es de 5mEq/l, el sodio plasmático es de 140mEq/l y la creatinina urinaria es de 25 mg/dl. La causa más probable de su alteración de la función renal es:**

A) Hipovolemia con compromiso prerrenal
B) Necrosis tubular aguda
C) Nefropatía diabética
D) Nefritis intersticial
E) Rabdomiolisis

PREGUNTA 16 1.10.2.004

**16. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hemorragia subaracnoídea por rotura de un aneurisma?**

A) Cefalea opresiva occipital, con dolor a la palpación de los músculos cervicales posteriores
B) Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos
C) Cefalea intensa, pulsátil, frontal, asociada a fotopsias
D) Cefalea de rápida instalación, asociada a hemiparesia derecha y abolición de los reflejos osteotendíneos derechos
E) Cefalea progresiva, mayor con el decúbito, asociado a vómitos y edema de papila

PREGUNTA 17 1.10.2.008

**17. Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x', PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A) Resonancia magnética nuclear de cerebro
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro con contraste
D) Angiografía cerebral
E) Ecocardiograma

PREGUNTA 18 1.10.2.005

**18. Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?**

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

## BLOQUE 2 CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

PREGUNTA 19 1.10.2.016

**19. [URGENCIA: urémico, etc) · 1.10.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de urémico, etc). Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 20 1.10.2.017

**20. [URGENCIA: con meningitis purulenta o bacteriana · 1.10.2.017] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de con meningitis purulenta o bacteriana. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 21 1.10.2.015

**21. Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm3, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste aracnoidal
B) Astrocitoma pilocítico
C) Encefalitis herpética
D) Meningitis tuberculosa
E) Neurocisticercosis

PREGUNTA 22 1.10.1.001

**22. Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cefalea tensional
B) Migraña
C) Cefalea en racimo o cluster
D) Cefalea por hipertensión endocraneana
E) Neuralgia de Arnold

PREGUNTA 23 1.10.1.012

**23. Existen tratamientos profilácticos para la migraña, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios de jaqueca. Todos los medicamentos enumerados a continuación pueden ser usados como tratamiento profiláctico, EXCEPTO:**

A) Sumatriptán
B) Propanolol
C) Ácido valproico6
D) Flunarizina
E) Amitriptilina

PREGUNTA 24 1.10.1.018

**24. Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol de una botella de vino de 750 cc durante los fines de semana, consulta por dificultades para caminar y hablar de 3 meses de evolución, progresivas, asociadas a torpeza de las extremidades. No ha presentado náuseas ni cefalea. Al examen Fsico, se aprecia ataxia de la marcha, habla disártrica y dismetría de las extremidades superiores, con imposibilidad de realizar movimientos alternantes de forma coordinada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Toxicidad cerebelosa por bromhexina
B) Degeneración cerebelosa alcohólica
C) Esclerosis múl2ple
D) Síndrome paraneoplásico
E) Tumor cerebeloso

PREGUNTA 25 1.10.1.019

**25. Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con an8inflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual, desde hace dos meses, que inicialmente era mayor durante la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Síndrome de hipertensión endocraneana
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopaaa hipertensiva
D) Tumor cerebral
E) Cefalea por ergotamínicos

PREGUNTA 26 1.10.1.021

**26. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis) · 1.10.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis). El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 27 1.10.1.022

**27. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes convulsivos sintomáticos · 1.10.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes convulsivos sintomáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 28 1.10.1.023

**28. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes sensitivos · 1.10.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes sensitivos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 29 1.10.1.024

**29. Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vér8go intenso de inicio súbito hace 2 horas, asociado a dificultades en la marcha que le impiden mantenerse de pie. Al examen Fsico se observa hipotónico, con dismetría de extremidades y nistagmus mul8direccional. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar difenidol
B) Realizar examen de VIII par
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de troncoencéfalo
E) Solicitar TAC de cerebro

PREGUNTA 30 1.10.2.014

**30. Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm3, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm3, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Toxoplasmosis cerebral
B) Meningoencefalitis herpética
C) Tumor cerebral
D) Meningitis viral
E) Meningitis bacteriana aguda

PREGUNTA 31 1.10.1.013

**31. Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?**

A) Pregabalina
B) Tramadol
C) Prednisona
D) Paracetamol y AINEs
E) Amoxicilina

PREGUNTA 32 1.10.2.012

**32. [URGENCIA: Síndrome cuadraplégico agudo · 1.10.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Síndrome cuadraplégico agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 33 1.10.1.007

**33. Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Suspender por completo los videojuegos
B) Ácido valproico
C) Carbamazepina
D) Melatonina en la noche
E) Diazepam si convulsiona nuevamente

PREGUNTA 34 1.10.2.010

**34. [URGENCIA: Movimientos anormales inducidos por fármacos · 1.10.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Movimientos anormales inducidos por fármacos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 35 1.10.2.018

**35. Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico. ¿Qué fármaco debe administrar?**

A) Lidocaína
B) Barbitúricos
C) Sulfato de magnesio
D) Fenitoína
E) Lamotrigina

PREGUNTA 36 1.10.2.019

**36. [URGENCIA: Status migrañoso · 1.10.2.019] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Status migrañoso. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

PREGUNTA 37 1.10.1.004

**37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores · 1.10.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.10.1.028

**38. Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen físico, tiene hemianopsia heterónima, sin alteraciones motoras ni de la sensibilidad. ¿En qué estructura anatómica se encuentra con mayor probabilidad la lesión?**

A) En las retinas
B) En ambos nervios ópticos
C) En el lóbulo occipital
D) En la radiación óptica
E) En el quiasma óptimo

PREGUNTA 39 1.10.1.029

**39. Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares. INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:**

A) Neurofibromatosis tipo 1
B) Enfermedad de Addison
C) Enfermedad celiaca
D) Síndrome de Peutz-Jeghers
E) Hiperplasia suprarrenal congénita

PREGUNTA 40 1.10.1.006

**40. Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Polineuropatía diabética
D) Polimialgia reumática
E) Miopatía por cuerpos de inclusión

PREGUNTA 41 1.10.1.006

**41. El temblor de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por:**

A) Ser postural
B) Asociarse a aumento del pestañeo
C) Ser de intención
D) Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos
E) Asociarse a una marcha con aumento de la base de sustentación y pasos largos

PREGUNTA 42 1.10.1.006

**42. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedada de Parkinson idiopática?:**

A) Demencia al inicio
B) Mioclonías.
C) Blefaroespasmo.
D) Retrocollis.
E) Pérdida de movimientos asociados en la marcha.

PREGUNTA 43 1.10.1.006

**43. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce parkinsonismo por drogas con más frecuencia?**

A) Clozapina
B) Risperidona
C) Carbamacepina
D) Ergotamina
E) Amitriptilina

PREGUNTA 44 1.10.1.006

**44. Una paciente de 22 años consulta por presentar desde una semana antes ptosis palpebral izquierda, sin dolor, con diplopía en al mirada lateral izquierda. En la exploración física se comla existencia de una ptosis izquierda, una paresia de la abducción del ojo izquierdo, con unas pupilas isocóricas y normorreactivas de la luz. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca la paciente?:**

A) Una neuritis óptica izquierda en relación con Esclerosis Múltiple.
B) Un síndrome de Horner.
C) Una Miastenia gravis.
D) Una parálisis del III par izquierdo.
E) Una miopatía hipertiroidea con afectación de la musculatura extraocular.

PREGUNTA 45 1.10.1.027

**45. Hombre de 65 años con antecedente de enfermedad de Parkinson. Su pareja refiere que durante el sueño emite gritos, golpea y patea. El paciente no recuerda nada al despertar. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno de conducta del sueño REM (RBD)
B) Sonambulismo
C) Terrores nocturnos
D) Apnea obstructiva del sueño
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

PREGUNTA 46 1.10.1.006

**46. Está usted evaluando unadiagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla: Enfermedad SÏ NO Prueba Positiva 80 100 Prueba Negativa 20 800 A partir de ella y redondeando decimales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:**

A) El valor predictivo positivo es del 56% y el valor predictivo negativo del 13%.
B) El valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%.
C) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 90%.
D) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 11%.
E) El valor predictivo positivo es del 10% y el valor predictivo negativo del 20%.

PREGUNTA 47 1.10.1.006

**47. Para determinar la relevancia de una enfermedad infecciosa grave conviene ocupar:**

A) Mortalidad general
B) Mortalidad específica
C) Incidencia
D) Prevalencia
E) Tasa de ataque

PREGUNTA 48 1.10.1.026

**48. Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa el mencionado temblor, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de sus síntomas?**

A) Diazepam
B) Alprazolam
C) Propranolol
D) Levodopa
E) Sertralina

PREGUNTA 49 1.10.1.026

**49. Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aumenta al adoptar una postura. Además se observa temblor del mentón y de la cabeza y el resto del examen neurológico es normal. El tratamiento de la patología descrita es:**

A) Antagonistas dopaminérgicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueoygeriatria/ 1/9
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

PREGUNTA 50 1.10.1.026

**50. Un paciente de 67 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que aumenta al adoptar alguna postura. Refiere que su madre presentó un cuadro similar. La marcha y la coordinación motora son normales y no presenta focalidad en el examen neurológico. El tratamiento de la patología descrita es:**

A) Antidepresivos tricíclicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueo
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

PREGUNTA 51 1.10.2.011

**51. [URGENCIA: Paraplejia aguda · 1.10.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paraplejia aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 52 1.10.1.005

**52. Paciente con 1 año de alucinaciones visuales, pérdida de memoria progresiva, rigidez, hipocinesia y alteración de la marcha. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Parkinson con demencia
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia frontotemporal
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Parálisis supranuclear progresiva

PREGUNTA 53 1.10.1.005

**53. ¿Qué medicamento se utiliza para el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada?**

A) Benzodiacepinas.
B) Neurolépticos atípicos.
C) Inhibidores de la monoaminooxidasa.
D) Antidepresivos tipo ISRS.
E) Inhibidores de la acetilcolinesterasa.

PREGUNTA 54 1.10.2.020

**54. [URGENCIA: Traumatismo encéfalo craneano leve · 1.10.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo encéfalo craneano leve. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

## BLOQUE 4 PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

PREGUNTA 55 1.10.1.009

**55.** **Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones vesiculares en esa zona. En el examen físico se observa curación de las lesiones, algunas de las que dejaron cicatrices, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del dolor?**

A) Pregabalina
B) Galantamina
C) Amitriptilina
D) Carbamazepina
E) Fluoxetina

PREGUNTA 56 1.10.1.010

**56.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbago mecánico · 1.10.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbago mecánico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 57 1.10.1.011

**57.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Lumbociáticas y cervicobraquialgias. · 1.10.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lumbociáticas y cervicobraquialgias.. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 1.10.1.017

**58.** **Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad "en calcetín", signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Radiculopatía S1
C) Síndrome de cola de caballo
D) Polineuropatía
E) Esclerosis lateral amiotrófica

PREGUNTA 59 1.10.2.013

**59.** **Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. El diagnóstico más probable es:**

A) Radiculopatía S1 derecho
B) Polineuropatía desmielinizante aguda
C) Meningitis viral
D) Mielopatía por influenza
E) Miositis viral

PREGUNTA 60 1.10.2.013

**60.** **¿Qué es lo más constante en el examen físico de un paciente con una síndrome de Guillain-Barré?**

A) Arreflexia
B) Hipoventilación
C) Compromiso de conciencia
D) Hipoestesia
E) Oftalmoplejia

PREGUNTA 61 1.10.2.013

**61.** **Un paciente de 34 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia debilidad progresiva para caminar y para mover las manos. Al examen físico se aprecia además parálisis fácil y arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia gravis
C) Polineuropatía
D) Botulismo
E) Intoxicación por marea roja

PREGUNTA 62 1.10.2.013

**62. Un adolescente de 16 años inicia un cuadro relativamente rápido de debilidad de las extremidades inferiores, que luego se extiende a las superiores, en cosa de 5 horas, agravándose a medida que pasa el tiempo. Al examen físico además se constata arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:**

A) Polineuropatía
B) Síndrome de Guillain- Barre
C) Síndrome de compresión medular
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

PREGUNTA 63 1.10.2.013

**63. Un paciente de 36 años presenta disestesias en las piernas, asociadas a debilidad progresiva, que a las 48 horas de su inicio le impide la marcha. Al examen se aprecia arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:**

A) Polirradiculoneuritis desmielinizante
B) Síndrome de arteria espinal posterior
C) Mononeuritis múltiple
D) Polineuropatía
E) Esclerosis múltiple

PREGUNTA 64 1.10.1.020

**64. Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace un mes. Además, refiere ptosis a derecha, que suele ser mayor en las tardes. Al examen físico se constata ptosis bilateral, mayor a derecha, con normalidad de los reflejos osteotendíneos y la sensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esclerosis lateal amiotrófica
B) Polimiositis
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

PREGUNTA 65 1.10.1.020

**65. Lo más característico de la miastenia gravis es:**

A) Debilidad de instalación súbita de un hemicuerpo
B) Debilidad proximal, asociada a elevación de la creatinfosfoquinasa (CK)
C) Debilidad distal asimétrica que mejora con el ejercicio
D) Debilidad proximal y distal simétricas, sin compromiso ocular
E) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante

PREGUNTA 66 1.10.1.020

**66. Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis izquierda y ligero estrabismo divergente, que ella refiere no haber tenido previamente. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome de Guillan Barré7
B) Miastenia gravis
C) Tumor hipofisiario
D) Encefalopatía de Wernicke
E) Síndrome de Claude Bernard Horner

PREGUNTA 67 1.10.1.020

**67. Una mujer de 33 años consulta por astenia y debilidad fluctuantes, asociadas a diplopía, que se agrava al realizar deporte. El diagnóstico de sospecha es:**

A) Botulismo
B) Polineuropatía
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Miastenia gravis
E) Esclerosis múltiple

PREGUNTA 68 1.10.1.008

**68. Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. El diagnóstico más probable es:**

A) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B) Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
C) Infarto talámico
D) Esclerosis múltiple
E) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

PREGUNTA 69 1.10.1.014

**69. Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuropatía diabética simétrica sensitiva
B) Contractura de Dupuytren
C) Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
D) Artritis reumatoide
E) Síndrome del túnel carpiano

PREGUNTA 70 1.10.1.015

**70. Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades, que trae problemas para caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. Se solicita espirometría que se muestra a continuación ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Polineuropatía diabética
B) Distrofia muscular
C) Esclerosis múltiple
E) Esclerosis lateral amiotrófica
E) Hemograma y VHS

PREGUNTA 71 1.10.1.016

**71. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?**

A) Mantener la capacidad de arrugar la frente y cerrar el ojo derecho
B) Compromiso de músculos masticatorios derechos
C) Presencia de hemiparesia braquiocrural derecha
D) Presencia de hemihipoestesia facial derecha
E) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón

PREGUNTA 72 1.10.1.025

**72. Un paciente consulta porque hoy al despertar presentó vértigo muy intenso, que inició en el momento en que se levantó de la cama. El vértigo dura algunos segundos y se desencadena con los movimientos de la cabeza. No ha presentado síntomas auditivos. Al examen destaca nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Meniere
B) Vértigo postural paroxístico benigno
C) Neuronitis vestibular
D) Laberintitis aguda
E) Infarto de cerebelo

## BLOQUE 5 GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

PREGUNTA 73 1.10.1.002

**73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Compromiso de conciencia · 1.10.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Compromiso de conciencia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 1.10.2.006

**74. Una paciente de 20 años es encontrada inconsciente en el baño por sus familiares, con el piloto del calefont apagado, por lo que es llevada al servicio de urgencia de inmediato, recuperándose parcialmente en el camino. Al examen físico está consciente, responde al interrogatorio y coopera, aunque está soporosa y se queja de muchas náuseas y cefalea intensa. Satura 97% a FiO2 ambiental, tiene frecuencia cardíaca de 90x' y presión arterial 146/92 mmHg. Su examen cardiopulmonar resulta normal. Cuál es el examen de elección para**

A) Radiografía de tórax
B) Resonancia magnética nuclear de cerebro
C) Carboxihemoglobina
D) Gases en sangre arterial
E) TAC de cerebro sin contraste

PREGUNTA 75 1.07.2.005

**75. El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:**

A) Compromiso de conciencia cualitativo, asociado a signos focales, de inicio agudo yygeriatria/ 5/10 curso fluctuante
B) Pérdida de la memoria de corto y largo plazo, asociado a compromiso de consciencia de inicio agudo
C) Desorientación, imposibilidad de mantener la atención, compromiso de conciencia y alucinaciones, de inicio agudo
D) Agitación psicomotora y alucinaciones visuales, sin compromiso de consciencia, de inicio agudo
E) Ideas paranoides, fallas en la memoria de largo plazo y compromiso de consciencia de inicio agudo

PREGUNTA 76 1.07.2.005

**76. El síndrome delirium se manifiesta clínicamente como:**

A) Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo de inicio agudo
B) Pérdida de la memoria de corto plazo y alucinaciones auditivas de inicio agudo
C) Desorientación y asterixis de instalación progresiva
D) Agitación psicomotora y convulsiones de inicio agudo
E) Ideas paranoides y fallas en la memoria de instalación progresiva

PREGUNTA 77 1.07.2.005

**77. El tratamiento de elección del delirium tremens es:**

A) Haldol
B) Diazepam
C) Etanol
D) Risperidona
E) Clorpromazina

PREGUNTA 78 1.07.2.005

**78. Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de memoria desde hace 3 a 4 años. Hace una semana lo notan apático y con comportamiento extraño. Hace tres días, salió de compras y un vecino debió traerlo a casa pues no recordaba el camino. Desde hace dos días habla incoherencias, se agita y presenta insomnio. El diagnóstico más probable es::**

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Demencia por cuerpos de Lewy
C) Trastorno psicótico
D) Demencia frontotemporal
E) Delirium

PREGUNTA 79 1.07.2.005

**79. En el enfrentamiento clínico sistemático de Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 1.07.2.005

**80. En el enfrentamiento clínico sistemático de Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 81 1.07.1.008

**81. Una mujer de 55 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T- score de -2,3 DS y un Z-score de -1 DS. El diagnóstico más probable es:**

A) Sano
B) Osteopenia
C) Osteoporosis primaria
D) Osteoporosis secundaria
E) Osteopetrosis

PREGUNTA 82 1.07.1.008

**82. ¿Por qué mecanismo se produce la mayor parte de las fracturas de cadera?**

A) Caídas a nivel
B) Caídas de altura
C) Rotación forzada
D) Fractura espontánea durante la marcha normal
E) Accidentes de tránsito

PREGUNTA 83 1.07.1.008

**83. En el enfrentamiento clínico sistemático de Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 84 1.07.1.008

**84. En el enfrentamiento clínico sistemático de Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 85 1.07.1.001

**85. ¿Cuál es la presentación clínica más habitual de las fracturas de cadera?**

A) Acortamiento, rotación interna y aducción del muslo, con imposibilidad de caminar
B) Acortamiento, rotación externa y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
C) Acortamiento, rotación interna y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
D) Posición púdica, equimosis, crujido articular y dolor intenso durante la marcha
E) Posición impúdica, aumento de volumen y dolor intenso durante la marcha

PREGUNTA 86 1.07.1.001

**86. ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocian a un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano?:**

A) Atenolol
B) Aspirina
C) Atorvastatina
D) Amoxicilina
E) Metformina

PREGUNTA 87 1.07.1.001

**87. En el enfrentamiento clínico sistemático de Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 88 1.07.3.007

**88. ¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requieren manejo estricto por especialista?**

A) Trauma ocular con discoria
B) Trauma ocular con hemorragia subconjuntival
C) Trauma ocular con herida palpebral, que compromete el borde libre
D) Trauma ocular con herida palpebral transfixiante
E) Trauma ocular con amaurosis

PREGUNTA 89 1.07.3.007

**89. Una paciente de 40 años, consulta por incontinencia urinaria, caracterizada por deseos incontrolables de orinar, que no le permiten llegar al baño, orinándose completamente. Se solicita urocultivo y sedimento de orina que resultan normales y se indican ejercicios y medidas conductuales, las que no muestran mayores beneficios. El tratamiento más adecuado es:**

A) Quirúrgico
B) Iniciar bloqueadores alfa-adrenérgicos
C) Iniciar anticolinérgicos
D) Iniciar betabloqueo
E) Iniciar agonistas dopaminérgicos

PREGUNTA 90 1.07.3.007

**90. En el enfrentamiento clínico sistemático de Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

**Hipertensión endocraneana**

1.10.2.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hipertensión endocraneana" como urgencia clínica (1.10.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 2 Respuesta: B

**Traumatismo encefalocraneano grave**

1.10.2.021 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: No requiere

Es un hematoma epidural clásico, tanto por la fractura, como por la clínica de HTEC grave, como por el breve intervalo lúcido.

### PREGUNTA 3 Respuesta: C

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es la C (Realizar endarterectomía derecha). La razón principal radica en la presencia de una estenosis carotídea significativa (60%) en el lado derecho, en un paciente que ha sufrido un AVE isquémico reciente. * **Estenosis Carotídea Sintomática:** La estenosis carotídea se considera sintomática porque el paciente ya tuvo un evento isquémico (AVE). Las guías internacionales y la evidencia disponible indican que la endarterectomía carotídea (o en algunos casos, la angioplastia con stent) es beneficiosa en pacientes sintomáticos con estenosis entre 50-99% (según algunas guías, el umbral puede ser 70% en otras). El objetivo es reducir el riesgo de un nuevo evento isquémico. * **Oportunidad:** El paciente fue manejado oportunamente con trombólisis, lo cual sugiere que se encuentra en una ventana de tiempo en la que la intervención quirúrgica carotídea puede ser realizada de forma segura y efectiva para prevenir futuros eventos. * **Lado Afectado:** La estenosis del 60% en el lado derecho es la más significativa y, por lo tanto, la que requiere intervención. Aunque existe una estenosis del 40% en el lado izquierdo, esta no alcanza el umbral para la intervención quirúrgica en un paciente sintomático, al menos no de forma inmediata. **Importante:** Si bien no contamos con una guía clínica MINSAL específica para el manejo de la estenosis carotídea sintomática post-AVE, la evidencia internacional (como las guías de la American Heart Association/American Stroke Association) son consistentes en recomendar la intervención en estenosis significativas en pacientes sintomáticos. El juicio clínico y la discusión del caso con un equipo multidisciplinario (neurólogo, cirujano vascular) son fundamentales.

**PREGUNTA 4** **Respuesta: C**

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La alternativa correcta es la C (Realizar endarterectomía derecha). La razón principal radica en la presencia de una estenosis carotídea significativa (60%) en el lado derecho, en un paciente que ha sufrido un AVE isquémico reciente. * **Estenosis Carotídea Sintomática:** La estenosis carotídea se considera sintomática porque el paciente ya tuvo un evento isquémico (AVE). Las guías internacionales y la evidencia disponible indican que la endarterectomía carotídea (o en algunos casos, la angioplastia con stent) es beneficiosa en pacientes sintomáticos con estenosis entre 50-99% (según algunas guías, el umbral puede ser 70% en otras). El objetivo es reducir el riesgo de un nuevo evento isquémico. * **Oportunidad:** El paciente fue manejado oportunamente con trombólisis, lo cual sugiere que se encuentra en una ventana de tiempo en la que la intervención quirúrgica carotídea puede ser realizada de forma segura y efectiva para prevenir futuros eventos. * **Lado Afectado:** La estenosis del 60% en el lado derecho es la más significativa y, por lo tanto, la que requiere intervención. Aunque existe una estenosis del 40% en el lado izquierdo, esta no alcanza el umbral para la intervención quirúrgica en un paciente sintomático, al menos no de forma inmediata. **Importante:** Si bien no contamos con una guía clínica MINSAL específica para el manejo de la estenosis carotídea sintomática post-AVE, la evidencia internacional (como las guías de la American Heart Association/American Stroke Association) son consistentes en recomendar la intervención en estenosis significativas en pacientes sintomáticos. El juicio clínico y la discusión del caso con un equipo multidisciplinario (neurólogo, cirujano vascular) son fundamentales.

---

**PREGUNTA 5** **Respuesta: C**

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

El paciente presenta un cuadro compatible con un accidente isquémico transitorio (AIT) o un infarto cerebral menor con recuperación espontánea temprana. La aparición súbita de déficit neurológico focal (hemiparesia derecha y afasia), la duración breve (30 minutos) y la recuperación completa antes de las 48 horas (en este caso, al segundo día), sin evidencia de hemorragia en la TAC inicial, son características clave. Un AIT es un evento isquémico cerebral que causa síntomas neurológicos transitorios sin evidencia de infarto agudo en las pruebas de imagen. Sin embargo, clínicamente, el abordaje diagnóstico y la urgencia son idénticos a los de un ACV isquémico, ya que un AIT es un fuerte predictor de un ACV inminente. La conducta más adecuada es buscar la etiología subyacente de este evento isquémico para implementar medidas de prevención secundaria específicas y efectivas. Las causas más comunes de AIT/ACV isquémico incluyen: enfermedad aterosclerótica de grandes vasos (especialmente carotídea), fuentes cardioembólicas (como fibrilación auricular, enfermedad valvular, foramen oval permeable, trombos intracavitarios) y enfermedad de pequeños vasos. La solicitud de un Holter de arritmias busca detectar fibrilación auricular paroxística; el ecocardiograma evalúa el corazón como posible fuente de émbolos (válvulas, función ventricular, trombos, foramen oval); y el eco-doppler carotídeo evalúa la presencia de estenosis carotídea significativa, una causa tratable de ACV. Identificar la causa permitirá instaurar el tratamiento más adecuado (por ejemplo, anticoagulación para fibrilación auricular, endarterectomía o stenting para estenosis carotídea severa).

---

**PREGUNTA 6** **Respuesta: A**

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.001, 1.10.2.007

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La alternativa correcta es solicitar un TAC de cerebro sin contraste debido a la sospecha clínica de un accidente cerebrovascular (ACV) agudo. El paciente presenta una hemiparesia izquierda de inicio súbito, acompañada de hemihipoestesia ipsilateral, lo cual sugiere fuertemente un evento isquémico o hemorrágico en el hemisferio derecho. El TAC de cerebro sin contraste es el estudio de neuroimagen de primera línea para diferenciar entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. Esta diferenciación es crucial porque el tratamiento para cada uno es completamente distinto. En el ACV isquémico, se considera la trombolisis o trombectomía mecánica, mientras que en el ACV hemorrágico, estos tratamientos están contraindicados. La rapidez en la obtención del TAC es fundamental para determinar la elegibilidad del paciente para terapias de reperfusión en caso de ACV isquémico. Las Guías Clínicas MINSAL para el manejo del ACV isquémico establecen que la neuroimagen debe obtenerse idealmente dentro de los primeros 25 minutos desde el arribo del paciente al servicio de urgencias.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: E**

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.001, 1.10.2.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Estamos ante un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico (ACV isquémico) agudo. Los síntomas (afasia y hemiparesia) comenzaron hace solo 1 hora, y la TAC inicial no muestra hemorragia. Esto es crucial, ya que la ausencia de hemorragia en la TAC es un criterio de inclusión para la trombolisis con activador tisular del plasminógeno (tPA). El tiempo es cerebro, y cada minuto cuenta en estos casos. La trombolisis es el tratamiento de elección en la fase aguda del ACV isquémico, dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas (y hasta 3 horas en algunos centros, aunque la ventana se está expandiendo). El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo al área cerebral afectada y minimizar el daño. La guía clínica del MINSAL para el manejo del ACV isquémico enfatiza la importancia del reconocimiento temprano de los síntomas y la rápida administración de tPA en pacientes elegibles. El paciente cumple con los criterios de inclusión para la trombolisis: déficit neurológico agudo, inicio de los síntomas dentro de la ventana terapéutica y ausencia de hemorragia en la TAC.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: E**

**Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES**

1.10.2.007 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene un AVE diagnosticado (se diagnostica con la clínica de signos focales de inicio súbito). La TAC se pide solo para diferenciar los AVE hemorrágicos, de los isquémicos y, en este caso, por estar normal la TAC se confirma que no es hemorrágico, sino isquémico. Por tener menos de 4,5 horas de evolución, está dentro de la ventana de trombolíticos, que es lo más urgente (rTPA ev).

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

**Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria**

1.10.2.002 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente. La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: E**

**Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria**

1.10.2.002 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La respuesta correcta es (e) debido a que el paciente presenta un Ataque Isquémico Transitorio (AIT) de alto riesgo. Un AIT se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, medular o retiniana, sin infarto agudo. En este caso, la sintomatología (afasia y hemiparesia derecha) es altamente sugestiva de isquemia cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y la resolución espontánea en 30 minutos cumple con la definición de AIT. El factor de riesgo crucial es la Fibrilación Auricular Crónica (ACxFA), la causa más frecuente de accidente cerebrovascular cardioembólico. A pesar de estar en tratamiento con aspirina, la aparición de un AIT con ACxFA indica un fracaso de la profilaxis antiplaquetaria y una necesidad urgente de cambiar a anticoagulación. La hospitalización es imperativa en pacientes con AIT de alto riesgo, como aquellos con fibrilación auricular, para una evaluación rápida y exhaustiva y para iniciar la prevención secundaria de forma inmediata. El riesgo de un accidente cerebrovascular (ACV) después de un AIT es máximo en las primeras horas a días. La resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro con secuencia de difusión (DWI) es el estudio de imagen más sensible para detectar isquemia aguda, incluso en casos donde la TAC cerebral puede ser normal. Iniciar anticoagulación con heparina (ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular) es la medida más adecuada para prevenir un evento isquémico recurrente en un paciente con AIT de origen cardioembólico por ACxFA, proporcionando un efecto anticoagulante rápido mientras se espera la estratificación y el inicio de la anticoagulación oral a largo plazo. Las "medidas de neuroprotección" en este contexto se refieren a un manejo integral para optimizar el pronóstico, incluyendo el control estricto de factores de riesgo como la presión arterial, la glucemia y el manejo de lípidos, además de la anticoagulación efectiva para prevenir un ACV establecido.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: C**

**Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos** 1.10.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hematoma subdural crónico en adulto mayor: cefalea crónica + ataxia + deterioro cognitivo + colección hipodensa (crónica >3 semanas) entre córtex y cráneo en TAC = hematoma subdural crónico. Frecuentemente sin traumatismo recordado. Tratamiento: trépano de drenaje si sintomático.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

**Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos** 1.10.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 166). Evalúa el manejo clínico de Crisis convulsiva según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: D**

**Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos** 1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El caso clínico describe un paciente pediátrico con un síndrome meníngeo clásico (cefalea, fiebre, rigidez de nuca). La clave para el diagnóstico diferencial se encuentra en el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR). Las características del LCR del paciente son: 1. **Aspecto**: Claro, lo que sugiere una meningitis no purulenta. 2. **Celularidad**: 60 células/mm³, lo que indica una pleocitosis leve a moderada (lo normal es < 5 células). 3. **Predominio celular**: 99% de mononucleares (linfocitos). Este es el dato más importante, ya que una **pleocitosis a predominio linfocitario** es característica de meningitis virales, tuberculosas o fúngicas, y descarta una meningitis bacteriana típica. 4. **Proteínas**: 50 mg/dl. Ligeramente elevadas o en el límite alto de la normalidad (normal < 45 mg/dl), lo cual es compatible con una inflamación meníngea leve. 5. **Glucosa**: 60 mg/dl. Este valor se considera normal (**normoglucorraquia**), especialmente si se asume una glicemia sérica normal (aprox. 80-100 mg/dl), manteniendo una relación LCR/plasma > 0.6. La combinación de pleocitosis leve a predominio linfocitario, con proteínas levemente elevadas y glucosa normal, es el patrón clásico y más frecuente de una **meningitis viral** (también llamada meningitis aséptica). Los enterovirus son la causa más común en este grupo de edad.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: D**

**Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos** 1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Este caso presenta a un paciente diabético mal controlado con un cuadro de neumonía grave que evoluciona a shock séptico (hipotensión, taquicardia, taquipnea, compromiso de conciencia). La probabilidad de una neumonía adquirida en la comunidad (NAC) complicada, con factores de riesgo para patógenos resistentes, es alta. El paciente cumple criterios de gravedad que obligan a hospitalización en UCI. El tratamiento empírico debe cubrir los patógenos más frecuentes, incluyendo *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* (incluyendo considerar SARM en paciente con factores de riesgo), y *Legionella pneumophila*. Además, el paciente tiene diabetes, lo que lo hace más susceptible a infecciones por organismos atípicos. La guía GES Neumonía Adquirida en la Comunidad del MINSAL (2013, aunque está pendiente una actualización) recomienda para pacientes hospitalizados con neumonía grave, una combinación de un betalactámico de amplio espectro (como ceftriaxona o cefotaxima) más un macrólido (como claritromicina o azitromicina) o una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacino). El macrólido cubre *Legionella* y otros atípicos.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

**Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos**

1.10.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es **Hipovolemia con compromiso prerrenal**. El cuadro clínico se presenta en el contexto de un trauma con hipotensión, una causa clásica de hipoperfusión renal que lleva a una Insuficiencia Renal Aguda (IRA) de tipo prerrenal. En este estado, los riñones están estructuralmente sanos, pero el flujo sanguíneo que reciben es insuficiente para mantener una tasa de filtración glomerular (TFG) normal. La clave para confirmar el diagnóstico y diferenciarlo de un daño intrínseco (como la necrosis tubular aguda) son los índices urinarios. En este caso, el riñón, al detectar la hipovolemia, activa intensamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, en un intento por restaurar el volumen circulante. Esto se traduce en una orina muy concentrada con una excreción de sodio extremadamente baja. Los valores del paciente son categóricos: un sodio urinario de 5mEq/l (típicamente <20 en prerrenal) y una Fracción Excretada de Sodio (FeNa) calculada de 0.5% ([(UNa x PCrea) / (PNa x UCrea)] x 100 = [(5 x 3.5) / (140 x 25)] x 100 = 0.5%). Un FeNa <1% es el sello distintivo de una causa prerrenal, ya que indica que la función tubular de reabsorción de sodio está intacta y ávida. Aunque la paciente ha comenzado a orinar y su presión ha mejorado, la creatinina sigue elevada porque la recuperación de la TFG puede ser más lenta que la restauración de la volemia y la diuresis.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

**Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino**

1.10.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción (b), "Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos", es la descripción más clásica y sugerente de una hemorragia subaracnoídea (HSA) por rotura de un aneurisma. La característica cardinal de la HSA es el "inicio súbito" de la cefalea, a menudo descrita como un "thunderclap headache" (cefalea en trueno), que alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos. Esta aparición abrupta se debe a la extravasación repentina de sangre en el espacio subaracnoídeo, lo que provoca una irritación meníngea masiva y un rápido aumento de la presión intracraneal. La intensidad "10/10" o "la peor cefalea de mi vida" es prácticamente patognomónica de una HSA, reflejando el dolor extremo causado por la irritación de las meninges y el aumento agudo de la presión. Los vómitos son un síntoma acompañante muy común, resultado de la estimulación de los centros eméticos en el tronco encefálico debido al incremento de la presión intracraneal. Esta combinación de inicio explosivo, dolor insoportable y síntomas vegetativos como los vómitos, convierte a la opción (b) en la presentación clínica que con mayor precisión apunta a una emergencia neuroquirúrgica como la HSA por aneurisma roto.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: D**

**Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino**

1.10.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene una angina crónica estable, por lo que se debe estudiar con un test de La...

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: C**

**Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena**

1.10.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades. La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido.

---

## BLOQUE 2 CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A** urémico, etc)

1.10.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "urémico, etc)" como urgencia clínica (1.10.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**con meningitis purulenta o bacteriana**

1.10.2.017 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "con meningitis purulenta o bacteriana" como urgencia clínica (1.10.2.017), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: E**

**Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas**

1.10.2.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Si bien es una pregunta rara, que tenga una lesión quística, más eosinófilos en el LCR hace que sea una neurocisticercosis por Taenia solium.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una cefalea tensional clásica (como la que da al salir del Eunacom).

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: A**

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

1.10.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La pregunta aborda el tratamiento profiláctico de la migraña, es decir, medicamentos que se usan de forma regular para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de jaqueca. La respuesta correcta, Sumatriptán, es la excepción porque no se utiliza para este propósito. El Sumatriptán pertenece a la clase de los triptanos, que son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1B/1D de serotonina. Su mecanismo de acción implica la vasoconstricción de los vasos sanguíneos craneales dilatados y la inhibición de la liberación de neuropéptidos proinflamatorios, lo que resulta en un alivio rápido del dolor y los síntomas asociados a un ataque agudo de migraña. Por lo tanto, el Sumatriptán es un tratamiento abortivo o agudo, diseñado para ser tomado al inicio de una crisis de migraña para detenerla, no para prevenir futuras crisis.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: D**

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

1.10.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta muy difícil, aunque Gene un claro síndrome cerebeloso. Sin embargo, no queda clara la causa. Tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, que puede producir una cerebeliGs autoinmune, siendo compaGble el cuadro con la velocidad que se instauró. No Gene náuseas ni cefalea para pensar en un tumor. El consumo de alcohol no es muy grande y el daño cerebeloso por alcohol suele ser de instalación mucho más lenta. La bromhexina no suele producir toxcicidad cerebelosa y, en caso de hacerlo, es muy raro. El ACV cerebeloso (no está en las opciones) suele instalarse de forma súbita. La esclerosis múlGple también se instala más rápido en algunos pocos días. En resumen, la velocidad con la que progresa hace pensar en una cerebeliGs autoinmune paraneoplásica.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

1.10.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

El predominio maGnal y la presencia de náuseas y vómitos orienta a hipertensión endocraneana (HTEC). De hecho, el síndrome de HTEC completo es cefalea de predominio maGnal, náuseas / vómitos y edema de papila en el fondo de ojo. Por ello, se debe realizar un fondo de ojo y solicitar una neuroimagen.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: A**

1.10.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis)" (1.10.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

1.10.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes convulsivos sintomáticos" (1.10.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

1.10.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes sensitivos" (1.10.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: E**

1.10.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

Tiene un vérGgo de Gpo central, por el nistagmo mulGdireccional y la dismetría (propio de los síndromes cerebelosos). Con ello, se debe solicitar una neuroimagen. Si bien la RMN ve mejor la fosa posterior y, probablemente, se solicite después, lo más urgente es la TAC de cerebro, ya que es un examen rápido y la primera sospecha es un ACV cerebeloso o del sistema vertebrobasilar, que está dentro de la ventana de trombólisis, en caso de que sea isquémico.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

1.10.2.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

**Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional**

Es una encefalitis herpética clásica: anteraciones conductuales, convulsiones, compromiso de conciencia, líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis viral, pero hemorrágico. Lo unico raro era la edad, ya que suele afectar a personas más jóvenes.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: D**

1.10.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo**

Es una neuralgia del trigémino y de primera línea se dan carbamazepina u otros anticonvulsivantes, aunque también sirven los antidepresivos tricíclicos. De segunda línea, se puede agregar la pregabalina (lo habitual es CBZ y luego pregabalina).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

**Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo**

1.10.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Síndrome cuadraplégico agudo" como urgencia clínica (1.10.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

**Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES**

1.10.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una epilepsia mioclónica. Los niños con epilepsia sí pueden ver pantallas, pero máximo 1 hora al día, con una buena iluminación.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: A**

**Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES**

1.10.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Movimientos anormales inducidos por fármacos" como urgencia clínica (1.10.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

**Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo**

1.10.2.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El estatus epiléptico en un recién nacido, especialmente en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia, es una emergencia neurológica que requiere tratamiento inmediato para prevenir un mayor daño cerebral. El manejo de las convulsiones neonatales sigue un algoritmo escalonado. El fármaco de primera línea o, en su defecto, el segundo tras el fracaso de las benzodiacepinas (que no están en las opciones), es el **fenobarbital**, un tipo de **barbitúrico**. El fenobarbital es el anticonvulsivo más estudiado y utilizado en el período neonatal. Actúa potenciando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA, lo que ayuda a suprimir la actividad eléctrica cerebral anómala y detener las convulsiones. Dada la gravedad del cuadro (estatus epiléptico) y las opciones disponibles, los barbitúricos son la elección correcta y estándar en la práctica clínica neonatal.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

**Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo**

1.10.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Status migrañoso" como urgencia clínica (1.10.2.019), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

**Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores**

1.10.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores" (1.10.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: E** **Tumores de región sellar** 1.10.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tumor Hipofisario con Compromiso del Quiasma Óptico: La sospecha es un tumor hipofisario que afecta el quiasma óptico, causando hemianopsia heterónima bitemporal. La alteración del nervio óptico produce amaurosis, mientras que las lesiones del lóbulo occipital, radiaciones y cintilla óptica se manifiestan como hemianopsia homónima contralateral.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A**

**Tumores primarios y metastásicos SNC**

1.10.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Eran manchas café con leche, que si son más de 6, se asocian a NF1.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: A**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es una anfermedad de Parkinson clásico: temblor de reposo, bradicinesia y problemas de inicio de marcha.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: D**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta, D) "Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos", describe de manera precisa el temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Este es el síntoma motor cardinal más distintivo y a menudo el primero en manifestarse. Se conoce como temblor de reposo porque aparece cuando la extremidad (brazo, pierna o mano) está completamente relajada y apoyada, es decir, sin ninguna actividad muscular voluntaria ni sosteniéndose contra la gravedad. Típicamente, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz y se describe comúnmente como un "signo de contar monedas" o "pill-rolling" por el movimiento repetitivo del pulgar y el índice. Una característica fundamental de este temblor es que disminuye o incluso desaparece por completo durante el movimiento voluntario o intencional de la extremidad afectada, y reaparece cuando la extremidad vuelve al reposo. También suele desaparecer durante el sueño. Aunque algunos pacientes pueden desarrollar un componente postural o cinético leve con el avance de la enfermedad, el temblor de reposo es el rasgo distintivo y el principal criterio semiológico para su diagnóstico diferencial con otros trastornos del movimiento. Su intensidad puede variar, exacerbándose con el estrés emocional o la fatiga.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: E**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La pérdida de movimientos asociados en la marcha, como la reducción o ausencia del braceo de los brazos, es uno de los signos motores cardinales y tempranos de la Enfermedad de Parkinson idiopática. Este fenómeno es una manifestación de la bradicinesia/acinesia, que es la lentitud o dificultad para iniciar y ejecutar el movimiento, y la pérdida de movimientos automáticos. En la marcha parkinsoniana típica, además de la postura encorvada y el arrastre de pies, es característico observar cómo los brazos no se balancean de forma rítmica y simétrica como lo harían en una persona sana, o incluso permanecen rígidamente pegados al cuerpo. Este hallazgo es muy frecuente porque se relaciona directamente con el déficit dopaminérgico en los ganglios basales que subyace a la patogenia de la enfermedad. La alteración en el circuito motor provoca una dificultad para la ejecución fluida y coordinada de movimientos automáticos y semi-automáticos, de los cuales el braceo es un excelente ejemplo. La asimetría en el braceo es, de hecho, uno de los signos tempranos que a menudo son notados por familiares o el propio paciente, incluso antes de que se establezca un diagnóstico formal. Por lo tanto, la pérdida de movimientos asociados en la marcha, especialmente el braceo, es un criterio diagnóstico clave y un hallazgo motor muy prevalente y característico en la Enfermedad de Parkinson idiopática, presente desde las etapas iniciales de la enfermedad en la mayoría de los pacientes.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la Risperidona. La Risperidona es un antipsicótico atípico que ejerce su efecto bloqueando los receptores de dopamina D2 en el sistema nervioso central, particularmente en los ganglios basales. Este bloqueo dopaminérgico, similar al que ocurre en la enfermedad de Parkinson idiopática, puede manifestarse clínicamente como parkinsonismo inducido por fármacos. Los síntomas suelen incluir bradicinesia (lentitud de movimiento), rigidez muscular, temblor en reposo y, en algunos casos, inestabilidad postural. La incidencia de parkinsonismo con la Risperidona es relativamente alta en comparación con otros antipsicóticos atípicos, aunque generalmente menor que con los antipsicóticos típicos de alta potencia. El riesgo de desarrollar parkinsonismo inducido por fármacos con Risperidona está relacionado con la dosis y la duración del tratamiento, así como con factores individuales del paciente como la edad y la presencia de otros trastornos neurológicos. Es importante destacar que, si bien la Clozapina (opción a) también es un antipsicótico atípico, tiene un riesgo significativamente menor de parkinsonismo, e incluso puede ser beneficiosa en algunos pacientes con Parkinson.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

La presentación clínica de la paciente es altamente sugestiva de Miastenia gravis (MG), específicamente de la forma ocular. La Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular, resultando en debilidad muscular fluctuante. Los síntomas oculares son la manifestación inicial en la mayoría de los casos y se caracterizan por ptosis (caída del párpado) y diplopía (visión doble), que empeoran con la fatiga y mejoran con el reposo. En este caso, la paciente presenta ptosis palpebral izquierda y diplopía en la mirada lateral izquierda debido a paresia de la abducción del ojo izquierdo, lo que indica debilidad del músculo recto lateral izquierdo (inervado por el VI par craneal). Un hallazgo crucial que orienta fuertemente hacia la Miastenia gravis y permite descartar otras causas de oftalmoplejía es la normalidad de las pupilas (isocóricas y normorreactivas a la luz). La Miastenia gravis afecta únicamente la musculatura estriada voluntaria y nunca las fibras autonómicas que controlan la pupila, ya que estas últimas poseen receptores muscarínicos de acetilcolina que no son el blanco de los autoanticuerpos miasténicos. La edad joven de la paciente (22 años) y el curso subagudo de los síntomas ("desde una semana antes") también son consistentes con el perfil de la Miastenia gravis.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras**

1.10.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Comportamientos violentos durante el sueño REM en paciente con Parkinson = trastorno de conducta del sueño REM (RBD). Es el parasomnia más frecuente en sinucleinopatías. El sujeto actúa sus sueños.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

**Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus**

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Para resolver esta pregunta, es fundamental comprender las definiciones y fórmulas del Valor Predictivo Positivo (VPP) y el Valor Predictivo Negativo (VPN), que son medidas de la utilidad de una prueba diagnóstica en la práctica clínica. Estas medidas dependen de la prevalencia de la enfermedad y se calculan a partir de los resultados de la prueba en individuos con y sin la enfermedad, como se presenta en la tabla de contingencia. La tabla proporcionada se interpreta de la siguiente manera: - Verdaderos Positivos (VP): Individuos con la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 80. - Falsos Positivos (FP): Individuos sin la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 100. - Falsos Negativos (FN): Individuos con la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 20. - Verdaderos Negativos (VN): Individuos sin la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 800. El Valor Predictivo Positivo (VPP) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPP = VP / (VP + FP). Calculando el VPP: VPP = 80 / (80 + 100) = 80 / 180 = 0.4444... Redondeado a porcentaje: 44%. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPN = VN / (FN + VN). Calculando el VPN: VPN = 800 / (20 + 800) = 800 / 820 = 0.9756... Redondeado a porcentaje: 98%. Por lo tanto, la afirmación verdadera es que el valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%, lo que corresponde a la opción B.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: C**

1.10.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus**

La incidencia es la medida epidemiológica más adecuada para determinar la "relevancia" de una enfermedad infecciosa grave. Se define como la tasa de aparición de nuevos casos de una enfermedad en una población específica durante un período determinado. Para una enfermedad infecciosa, la incidencia nos informa directamente sobre la velocidad a la que se está propagando y el número de personas que están contrayendo la infección recientemente. Conocer la incidencia de una enfermedad infecciosa grave es crucial para la salud pública y la toma de decisiones clínicas. Una alta incidencia indica que la enfermedad está activamente presente en la comunidad, que la transmisión es significativa y que existe un riesgo considerable de que un mayor número de personas enfermen. Esto permite a las autoridades sanitarias y a los profesionales médicos evaluar la magnitud del problema actual, predecir futuras cargas de enfermedad, implementar medidas de control y prevención (como campañas de vacunación, aislamiento o tratamiento temprano) y asignar recursos de manera efectiva. En resumen, la incidencia capta la dinámica de la enfermedad en tiempo real, reflejando su impacto y la urgencia de su abordaje en términos de nuevos contagios. Para una enfermedad infecciosa, especialmente una grave, su "relevancia" se asocia primariamente con su capacidad de infectar a nuevas personas y expandirse en la población, siendo la incidencia la métrica que mejor describe este fenómeno.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

**Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos**

Temblor Esencial: El cuadro clínico describe un temblor esencial, caracterizado por una exploración neurológica normal, salvo por temblor que aumenta con la postura o actividad. El tratamiento de elección es propranolol oral.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

**Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos**

El cuadro clínico presentado por el paciente de 72 años es altamente sugestivo de un **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave son: la edad del paciente (generalmente inicia en la adultez, pero es más notorio en personas mayores), el temblor que aumenta "al adoptar una postura" (lo que define un temblor postural, principal característica del TE), la afectación de las extremidades superiores (con predominio izquierdo, lo cual puede ocurrir en el TE, aunque a menudo es bilateral), y la presencia de temblor en el mentón y la cabeza (manifestaciones clásicas del TE). La ausencia de otros hallazgos neurológicos anormales descarta otras causas de temblor, como la enfermedad de Parkinson (que presentaría bradicinesia, rigidez y temblor de reposo) o temblor cerebeloso (que se asociaría a ataxia y temblor de intención). El tratamiento de primera línea para el Temblor Esencial son los **betabloqueantes**, siendo el Propranolol el fármaco más utilizado y estudiado. Actúa reduciendo la amplitud del temblor en aproximadamente el 50-70% de los pacientes, aunque el mecanismo exacto no se comprende completamente. Se cree que su efecto está relacionado con el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos periféricos, aunque también puede tener un efecto central. La opción "Betabloqueo" se refiere directamente a esta clase de fármacos. Por lo tanto, ante un diagnóstico claro de Temblor Esencial basado en las características del temblor y la normalidad del resto del examen neurológico, el tratamiento más apropiado y de primera elección es el betabloqueo.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: C**

1.10.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

**Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos**

El cuadro clínico presentado por el paciente de 67 años es altamente sugestivo de **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave que apoyan este diagnóstico son: el **temblor de las extremidades superiores que aumenta al adoptar alguna postura** (lo que describe un temblor postural, principal manifestación del TE), el antecedente de que **su madre presentó un cuadro similar** (destacando el fuerte componente genético y herencia autosómica dominante en muchos casos de TE), y la **normalidad de la marcha, coordinación motora y ausencia de focalidad en el examen neurológico**. Esta ausencia de otros signos neurológicos es crucial para diferenciarlo de otras patologías como la enfermedad de Parkinson (donde se esperaría temblor de reposo, bradicinesia y rigidez) o patologías cerebelosas (con ataxia y dismetría). El **betabloqueo**, específicamente con fármacos como el propranolol (un betabloqueante no selectivo), es el tratamiento farmacológico de primera línea más ampliamente recomendado y eficaz para el Temblor Esencial sintomático. El propranolol actúa reduciendo la amplitud del temblor, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Su mecanismo exacto no está completamente dilucidado, pero se cree que ejerce sus efectos tanto a nivel periférico (bloqueo de receptores beta-2) como a nivel central. La dosis se ajusta de forma individualizada para lograr el máximo beneficio con mínimos efectos adversos.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos**

1.10.2.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paraplejia aguda" como urgencia clínica (1.10.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: D**

**Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve**

1.10.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Demencia por cuerpos de Lewy

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: E**

**Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve**

1.10.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Control GES

La alternativa correcta es la E (Inhibidores de la acetilcolinesterasa). En el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada, los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE) como donepezilo, rivastigmina y galantamina son los fármacos de primera línea. Estos medicamentos actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina en la sinapsis neuronal. Al aumentar la disponibilidad de acetilcolina, mejoran la neurotransmisión colinérgica, lo que puede resultar en una leve mejoría en la función cognitiva, el comportamiento y las actividades de la vida diaria en algunos pacientes. Las guías clínicas del MINSAL (Programa Nacional de Salud Mental) recomiendan el uso de IAChE en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, considerando la relación riesgo-beneficio y la respuesta individual de cada paciente. Es fundamental el monitoreo regular y la evaluación de la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve**

1.10.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo encéfalo craneano leve" como urgencia clínica (1.10.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

## BLOQUE 4 PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Herpes zoster**

1.10.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Neuritis posherpética: La sospecha clínica es de neuritis posherpética. El tratamiento de primera línea es la pregabalina o la gabapentina, siendo la pregabalina la más utilizada. La carbamazepina o los antidepresivos tricíclicos, que antes eran el tratamiento de primera línea, ahora se consideran de segunda línea.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A** **Lumbago mecánico**

1.10.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbago mecánico" (1.10.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Lumbociáticas y cervicobraquialgias.**

1.10.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lumbociáticas y cervicobraquialgias." (1.10.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: D**

**Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...**

1.10.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

**Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo**

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Es un síndrome de Guillain Barré clásico

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A**

**Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo**

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda, de origen autoinmune, que afecta principalmente a los nervios periféricos. Su característica patológica principal es la desmielinización de las raíces nerviosas y nervios periféricos. Clínicamente, esto se manifiesta como un síndrome de **neurona motora inferior**, cuyos hallazgos cardinales son: 1. **Debilidad muscular:** Típicamente simétrica y de progresión ascendente (comienza en las extremidades inferiores y avanza hacia el tronco, extremidades superiores y músculos bulbares/respiratorios). 2. **Arreflexia o hiporreflexia osteotendinosa:** La interrupción de la vaina de mielina en el nervio periférico bloquea la conducción del impulso nervioso a lo largo del arco reflejo. Esto causa la abolición o disminución severa de los reflejos. La arreflexia es un hallazgo casi universal y es un criterio diagnóstico fundamental (por ejemplo, en los criterios de Brighton para el diagnóstico de SGB). Es, por lo tanto, el signo clínico **más constante y fiable** en el examen físico. La debilidad progresa durante días o hasta 4 semanas. Aunque existen otros signos y síntomas, la arreflexia generalizada en el contexto de una debilidad progresiva es el pilar del diagnóstico clínico.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo**

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la principal sospecha diagnóstica en este caso. La secuencia clásica es un evento infeccioso (en este caso, diarrea autolimitada) seguido por debilidad muscular ascendente y arreflexia. La parálisis facial refuerza aún más la sospecha, ya que es una manifestación común del SGB. La debilidad es progresiva y de tipo flácido, lo cual es consistente con el SGB. Según la Guía Clínica AUGE para el Síndrome de Guillain-Barré del MINSAL (aunque no se especifica un código en la lista proporcionada), el diagnóstico se basa en la clínica y se confirma con estudios como la electromiografía y el análisis del líquido cefalorraquídeo.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

**Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo**

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La alternativa correcta es el **Síndrome de Guillain-Barré (SGB)** porque el cuadro clínico del paciente, un adolescente de 16 años, se ajusta perfectamente a la presentación clásica de esta enfermedad. Los elementos clave son: * **Debilidad rápidamente progresiva:** La debilidad que asciende desde las extremidades inferiores a las superiores en cuestión de horas es muy sugerente de SGB. La rapidez de la progresión es fundamental. * **Arreflexia generalizada:** La ausencia de reflejos osteotendinosos (arreflexia) es un hallazgo cardinal en el SGB. Esto indica compromiso de las raíces nerviosas. * **Historia compatible:** Si bien la pregunta no lo explicita, es importante recordar que en muchos casos el SGB se presenta tras una infección respiratoria o gastrointestinal, lo que activaría una respuesta autoinmune. Si bien no se menciona en la pregunta, otros hallazgos que podrían apoyar el diagnóstico de SGB incluyen: * **Disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo (LCR):** Aumento de la proteína en el LCR con recuento celular normal o ligeramente elevado. * **Estudios de conducción nerviosa:** Demuestran desmielinización y/o axonal en los nervios periféricos. **Guías MINSAL:** Aunque no existe una guía clínica específica del MINSAL para el manejo del SGB en adolescentes, el manejo se basa en guías internacionales y la experiencia clínica. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son cruciales para minimizar la morbilidad y mortalidad. En Chile, el manejo suele realizarse en unidades de cuidados intensivos debido al riesgo de insuficiencia respiratoria.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo**

1.10.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La respuesta correcta es la a) Polirradiculoneuritis desmielinizante, que es el término técnico para el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Este diagnóstico encaja perfectamente con el cuadro clínico presentado. El paciente experimenta disestesias (alteraciones de la sensibilidad, como hormigueo o adormecimiento) en las piernas, asociadas a debilidad muscular progresiva que avanza rápidamente, impidiendo la marcha en tan solo 48 horas. Esta progresión aguda o subaguda de debilidad y síntomas sensitivos es una característica cardinal del SGB. El hallazgo más distintivo y confirmatorio en el examen físico es la arreflexia generalizada. La pérdida de los reflejos osteotendinosos profundos, especialmente de forma simétrica y generalizada, es un signo patognomónico del Síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que afecta las raíces nerviosas y los nervios periféricos. La edad del paciente (36 años) es también compatible, ya que el SGB puede afectar a cualquier edad. La polirradiculoneuritis desmielinizante aguda se caracteriza por una respuesta autoinmune dirigida contra la mielina de los nervios periféricos y/o las raíces nerviosas. Esto interrumpe la conducción nerviosa, llevando a la debilidad motora progresiva y la afectación sensitiva. La progresión rápida y la arreflexia son los pilares diagnósticos, haciendo de esta opción la más probable y precisa para la presentación clínica del paciente.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: E**

**Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma**

1.10.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Miastenia Gravis: El caso presentado corresponde a una miastenia gravis clásica. Se recomienda repasar el resumen de semiología neurológica.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: E**

**Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma**

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La respuesta correcta es la e) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante. La miastenia gravis se caracteriza por debilidad muscular que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Esta fluctuación es un sello distintivo de la enfermedad. La astenia, o sensación de fatiga, es un síntoma común. La debilidad afecta a menudo los músculos que controlan los ojos (ptosis, diplopía), la masticación, la deglución y las extremidades, pero la presentación varía considerablemente entre los pacientes. La fluctuación en la gravedad de los síntomas es clave para el diagnóstico y el manejo. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular. Los anticuerpos atacan a los receptores de acetilcolina en la placa motora, interfiriendo con la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Esto causa debilidad muscular que varía a lo largo del día y con la actividad. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico, pruebas farmacológicas (como el test del edrofonio) y pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos específicos. El tratamiento incluye medicamentos que mejoran la transmisión neuromuscular, inmunosupresores y, en algunos casos, timectomía.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

**Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma**

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La respuesta correcta es **b) Miastenia gravis**. Este diagnóstico se ajusta perfectamente a la presentación clínica de la paciente. La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad. Afecta predominantemente a mujeres jóvenes, lo que coincide con la edad de la paciente (33 años). Los síntomas clave en este caso son la astenia (debilidad generalizada o fatiga), la diplopía (visión doble) y la ptosis (caída del párpado), junto con un ligero estrabismo divergente. Todos estos son hallazgos clásicos de la MG, especialmente cuando afectan los músculos oculares (Miastenia Ocular), que es la forma de presentación inicial en aproximadamente el 50-60% de los casos. La característica más distintiva y crucial para el diagnóstico es la **fluctuación** de los síntomas: empeoran con la actividad o al final del día y mejoran con el reposo, lo que la paciente refiere como "fluctuantes". La evolución subaguda de 2 semanas es también consistente con el inicio de la enfermedad. La patogenia de la Miastenia Gravis implica la formación de autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo que impide la transmisión eficaz del impulso nervioso a los músculos y provoca la debilidad observada. El compromiso de los músculos extraoculares y de los párpados es muy común, llevando a ptosis y diplopía. La ausencia de antecedentes previos y la aparición de estos síntomas de forma subaguda y fluctuante refuerzan aún más el diagnóstico de Miastenia Gravis.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: D**

**Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma**

1.10.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Realizar GES

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune caracterizada por debilidad muscular fluctuante que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Los síntomas clásicos incluyen ptosis palpebral (caída del párpado), diplopía (visión doble), dificultad para hablar (disartria), dificultad para tragar (disfagia) y debilidad en las extremidades. El ejercicio exacerba la debilidad debido al agotamiento de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. En Chile, el manejo de la miastenia gravis está considerado en las Guías Clínicas del MINSAL, enfocándose en el diagnóstico precoz y tratamiento sintomático e inmunomodulador. La presentación fluctuante de los síntomas, su exacerbación con la actividad física y la presencia de diplopía son altamente sugestivas de miastenia gravis.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad**

1.10.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta difícil, pero el cuadro solo es compatible con una esclerosis múltiple ya que ha tenido múltiples signos focales, de inicio subagudo, que pueden recuperarse (como el trastorno del equilibrio). Revisar el resumen de semiología neurológica.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: E**

**Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento**

1.10.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Síndrome del Túnel Carpiano vs. Neuropatía Diabética: El paciente presenta un cuadro clínico compatible con síndrome del túnel carpiano. Se asocia a diabetes. El dolor nocturno y la desaparición de los síntomas con las actividades de la vida diaria son características distintivas del síndrome del túnel carpiano. En contraste, la neuropatía diabética simétrica sensitiva suele afectar primero a los pies y solo en etapas más avanzadas a las manos.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: E**

**Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento**

1.10.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una ELA clásica. La espirometría mostraba un patrón restrictivo.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: E**

1.10.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Realizar GES

**Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento**

La respuesta correcta es la **e) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón**. Este hallazgo es el más orientador de una parálisis facial periférica (o infranuclear) porque indica una afectación completa y homogénea de todos los músculos inervados por el nervio facial (VII par craneal) en el lado derecho. En una parálisis facial periférica, la lesión se localiza en el propio nervio facial, desde su núcleo en el tronco encefálico hasta su salida y ramificaciones, afectando por igual tanto las fibras que inervan la parte superior de la cara (músculo frontal para arrugar la frente, orbicular de los párpados para cerrar el ojo) como las que inervan la parte inferior (músculos de la boca, mejillas y mentón). El término "compromiso armónico" resalta esta afectación global: el paciente no podrá arrugar la frente del lado afectado, cerrar completamente el ojo (produciendo el signo de Bell), ni mover la boca o mejilla de manera simétrica (dificultad para sonreír, silbar, mostrar los dientes, y desviación de la comisura bucal hacia el lado sano). Esta distribución es clave para diferenciarla de una parálisis facial central. En contraste, una parálisis facial central (o supranuclear) se debe a una lesión en el cerebro (corteza o vías descendentes) y generalmente afecta solo la parte inferior contralateral de la cara, con preservación de la función de la frente y el ojo, debido a la inervación bilateral de los músculos de la parte superior de la cara. Por lo tanto, el compromiso armónico de todas las regiones faciales en un lado es el sello distintivo de una parálisis facial periférica.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

1.10.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS**

El diagnóstico más probable es **Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)**. El cuadro clínico descrito es la presentación clásica de esta patología. Analicemos las claves del caso: 1. **Desencadenante postural:** El vértigo "inició en el momento en que se levantó de la cama" y "se desencadena con los movimientos de la cabeza". Esta es la característica principal del VPPB, donde el vértigo es provocado por cambios específicos en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. 2. **Duración paroxística y breve:** Los episodios duran "algunos segundos". Esto es patognomónico del VPPB, cuyos episodios de vértigo rotatorio intenso suelen durar menos de un minuto. 3. **Ausencia de síntomas auditivos:** El paciente "no ha presentado síntomas auditivos" (como hipoacusia o tinnitus). El VPPB es una alteración puramente vestibular, causada por el desplazamiento de otoconias (cristales de carbonato de calcio) hacia los canales semicirculares, sin afectar la porción coclear (auditiva) del oído interno. 4. **Examen físico:** El "nistagmo horizontal" (que en el VPPB es más precisamente horizonto-rotatorio) es el signo objetivo que confirma la disfunción vestibular. Este nistagmo, al ser provocado por maniobras como la de Dix-Hallpike, típicamente tiene latencia, es de corta duración y se fatiga con la repetición de la maniobra, coincidiendo con el vértigo referido por el paciente. La combinación de vértigo rotatorio intenso, de corta duración, desencadenado por cambios posturales y sin síntomas auditivos asociados es el sello distintivo del Vértigo Postural Paroxístico Benigno.

---

## BLOQUE 5 GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Compromiso de conciencia** 1.10.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Compromiso de conciencia" (1.10.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: E**

1.10.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 99). Evalúa el manejo clínico de Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: C**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción C describe de manera precisa y completa las características clínicas cardinales del síndrome confusional agudo, también conocido como delirium. Este trastorno neurocognitivo agudo se define por una alteración en la atención y la conciencia que se desarrolla en un período corto (horas a días), representa un cambio con respecto a la atención y conciencia basales del individuo, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. Los elementos clave que lo caracterizan son la desorientación (temporal, espacial, e incluso personal), la imposibilidad de mantener o dirigir la atención (siendo este el rasgo distintivo), y un compromiso de la conciencia o del nivel de alerta. Además, las alucinaciones (frecuentemente visuales), los delirios y la agitación psicomotora son manifestaciones comunes de las alteraciones perceptivas y cognitivas asociadas. El inicio agudo es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción a) describe con precisión las características cardinales del síndrome delirium, también conocido como síndrome confusional agudo. El delirium es un trastorno neurocognitivo agudo caracterizado por una alteración de la atención y la conciencia que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días), representa un cambio agudo respecto al nivel basal de atención y conciencia del paciente, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. La "inatención" es la característica más distintiva, manifestándose como una dificultad para dirigir, enfocar, mantener o desviar la atención. El "compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo" se refiere a una alteración en el nivel de alerta (desde somnolencia o estupor hasta hipervigilancia o agitación) y en la claridad del pensamiento y la percepción del entorno. El "inicio agudo" es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias. Estas características son los criterios diagnósticos centrales para el delirium según el DSM-5.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La alternativa correcta es **B (Diazepam)**. El *delirium tremens* es una emergencia médica causada por la abstinencia alcohólica, caracterizada por hiperactividad autonómica (taquicardia, hipertensión, sudoración), temblor, alucinaciones (típicamente visuales), y riesgo de convulsiones. El tratamiento de elección se basa en **benzodiazepinas** (Diazepam, Lorazepam, Clordiazepóxido) debido a su efecto GABAérgico que contrarresta la hiperexcitabilidad neuronal resultante de la abstinencia. Diazepam es una opción comúnmente utilizada, especialmente si se busca una benzodiazepina de acción prolongada, aunque la elección específica depende de la disponibilidad y las características del paciente (función hepática, edad, etc.). El objetivo es la sedación suave y control de los síntomas de abstinencia, titular la dosis de manera cuidadosa. Si bien no existe una guía clínica del MINSAL específicamente sobre *delirium tremens*, el manejo de la abstinencia alcohólica severa se basa en las recomendaciones internacionales respaldadas por la evidencia y adaptadas a la realidad local.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: E**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La alternativa correcta es **E: Delirium**. El cuadro clínico describe una alteración aguda y fluctuante de la cognición, con inicio reciente (días), alteración del nivel de conciencia (apatía, agitación, insomnio) y alteraciones del pensamiento (incoherencias, desorientación). Estos son los criterios cardinales para el diagnóstico de Delirium. El antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, aunque no causan directamente el delirium, pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo, especialmente en un contexto de estrés fisiológico o metabólico. La pérdida leve de memoria previa podría ser un factor predisponente, pero la rapidez de la instalación del cuadro actual apunta fuertemente al delirium. Según la Guía Clínica del MINSAL para el manejo del Delirium, este se define como un síndrome neuropsiquiátrico agudo caracterizado por alteración de la atención, conciencia y cognición, que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días) y tiende a fluctuar a lo largo del día. En este caso, la evolución en días, la fluctuación del estado mental (apatía seguida de agitación) y la alteración de la cognición (incoherencias, desorientación) son consistentes con Delirium.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: A**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente, la conducta médica prioritaria es: El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente**

1.07.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Hospitalario / Ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente, la conducta médica prioritaria es: El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

**Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)**

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La pregunta se refiere a la interpretación de los resultados de una densitometría ósea en una mujer postmenopáusica, que es una situación clínica común evaluada en endocrinología. Para clasificar la densidad mineral ósea (DMO), se utilizan principalmente el T-score y, en menor medida, el Z-score. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el T-score es el parámetro clave para diagnosticar osteopenia u osteoporosis en mujeres postmenopáusicas (como la paciente de 55 años) y hombres mayores de 50 años. Los criterios de la OMS son los siguientes: * **DMO normal**: T-score igual o superior a -1.0 desviación estándar (DS). * **Osteopenia (baja masa ósea)**: T-score entre -1.0 y -2.5 DS. * **Osteoporosis**: T-score igual o inferior a -2.5 DS. * **Osteoporosis grave establecida**: T-score igual o inferior a -2.5 DS y la presencia de una o más fracturas por fragilidad. En el caso presentado, la paciente de 55 años tiene un T-score de -2.3 DS. Este valor se encuentra claramente entre -1.0 y -2.5 DS, lo que corresponde al diagnóstico de osteopenia. El Z-score de -1 DS compara la densidad ósea del paciente con la de personas de su misma edad y sexo. Aunque se menciona, el Z-score es más relevante para evaluar la DMO en niños, mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, donde un T-score negativo podría ser normal para la edad. Sin embargo, en una mujer postmenopáusica de 55 años, el T-score es el criterio diagnóstico definitivo.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)**

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La alternativa correcta es **A (Caídas a nivel)** porque la mayoría de las fracturas de cadera, especialmente en adultos mayores, se producen como resultado de caídas desde la propia altura. La fragilidad ósea asociada a la osteoporosis, común en este grupo etario, disminuye la resistencia del hueso, haciéndolo más susceptible a fracturas incluso con traumatismos de baja energía como una caída a nivel. La prevalencia de caídas a nivel es significativamente mayor que otras causas en la población de riesgo, según datos epidemiológicos y guías clínicas nacionales e internacionales. Aunque no hay una guía clínica MINSAL específica para fracturas de cadera, las guías sobre osteoporosis enfatizan la prevención de caídas como una medida clave.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)**

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI), la conducta médica prioritaria es: La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

**Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)**

1.07.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI), la conducta médica prioritaria es: La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

La alternativa correcta es la B porque la presentación clínica clásica de una fractura de cadera en el adulto mayor (grupo etario donde son más frecuentes) se caracteriza por: * **Acortamiento del miembro afectado:** Esto se debe a la tracción de los músculos de la cadera y el muslo sobre el fragmento distal de la fractura. * **Rotación externa del muslo:** La rotación externa es causada por la pérdida de la integridad ósea y la influencia de la gravedad y la tensión muscular, especialmente los rotadores externos de la cadera. * **Abducción del muslo:** Puede presentarse levemente debido a la posición antiálgica que adopta el paciente. * **Imposibilidad de caminar:** La fractura impide la carga de peso y el movimiento normal de la articulación de la cadera, generando dolor intenso e incapacidad funcional. En las guías clínicas chilenas del MINSAL no hay una específica sobre fractura de cadera, pero sí se enfatiza la importancia de la evaluación geriátrica integral en pacientes adultos mayores, donde la detección y manejo de fracturas de cadera es fundamental para disminuir la morbimortalidad.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A**

**Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

El Atenolol, al ser un betabloqueante selectivo beta-1, es un fármaco que se asocia con un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano debido a sus efectos cardiovasculares y, en menor medida, potenciales efectos en el sistema nervioso central. En la población geriátrica, la fisiología cardiovascular está alterada, con una respuesta barorrefleja más lenta y una menor reserva funcional. Los betabloqueantes reducen la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, lo que puede precipitar o exacerbar la hipotensión ortostática (una caída significativa de la presión arterial al ponerse de pie), causando mareos, aturdimiento y síncope. Estos síntomas de hipotensión ortostática o bradicardia son directamente predisponentes a la pérdida de equilibrio y, consecuentemente, a las caídas. Además, aunque el Atenolol es hidrofílico y tiene una menor penetración en el sistema nervioso central en comparación con otros betabloqueantes más lipofílicos, aún puede causar efectos como fatiga, debilidad o ligera sedación en algunos individuos, lo que también contribuye a una marcha inestable y un mayor riesgo de caídas. La polifarmacia, común en el adulto mayor, incrementa este riesgo al interactuar con otros fármacos que también pueden afectar el equilibrio o la presión arterial.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

**Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial / Derivación · Seg: Urgencia traumatológica / Ortogeriatría GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES, la conducta médica prioritaria es: Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: B**

**Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor**

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La hemorragia subconjuntival post-traumática, en ausencia de otros signos de alarma, generalmente es autolimitada y no requiere intervención urgente por un especialista. Se produce por la rotura de pequeños vasos sanguíneos bajo la conjuntiva, generalmente por un traumatismo leve, un esfuerzo (tos, vómito) o, a veces, sin causa aparente. El manejo suele ser expectante, con lubricación ocular si hay molestias. Si es recurrente o asociada a alteraciones de la coagulación o uso de anticoagulantes, se debe investigar la causa.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: C**

**Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor**

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

El caso clínico describe a una paciente con **Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU)**, también conocida como síndrome de vejiga hiperactiva "húmeda". El diagnóstico se basa en la sintomatología clave: "deseos incontrolables de orinar" (urgencia miccional) que provocan una pérdida involuntaria de orina antes de llegar al baño. El manejo de la IUU sigue un enfoque escalonado: 1. **Descartar causas reversibles:** Se realizó un urocultivo y sedimento de orina para descartar una infección del tracto urinario (ITU), que puede causar síntomas similares. Los resultados normales confirman que no hay una ITU. 2. **Tratamiento de primera línea:** Consiste en terapia conductual (ajuste de ingesta de líquidos, micciones programadas) y entrenamiento de los músculos del piso pélvico (ejercicios de Kegel). En el caso, estas medidas ya se indicaron y resultaron ineficaces. 3. **Tratamiento de segunda línea:** Cuando la primera línea falla, se inicia el tratamiento farmacológico. La fisiopatología de la IUU implica contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga, que está mediado principalmente por la estimulación colinérgica a través de receptores muscarínicos. Por lo tanto, los fármacos **anticolinérgicos (o antimuscarínicos)** son el tratamiento de elección. Estos medicamentos (como la oxibutinina, tolterodina o solifenacina) bloquean dichos receptores, relajando el músculo detrusor, aumentando la capacidad de la vejiga y disminuyendo la sensación de urgencia. Dado que la paciente ya falló al tratamiento de primera línea, el siguiente paso correcto y más adecuado es iniciar la farmacoterapia con anticolinérgicos.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

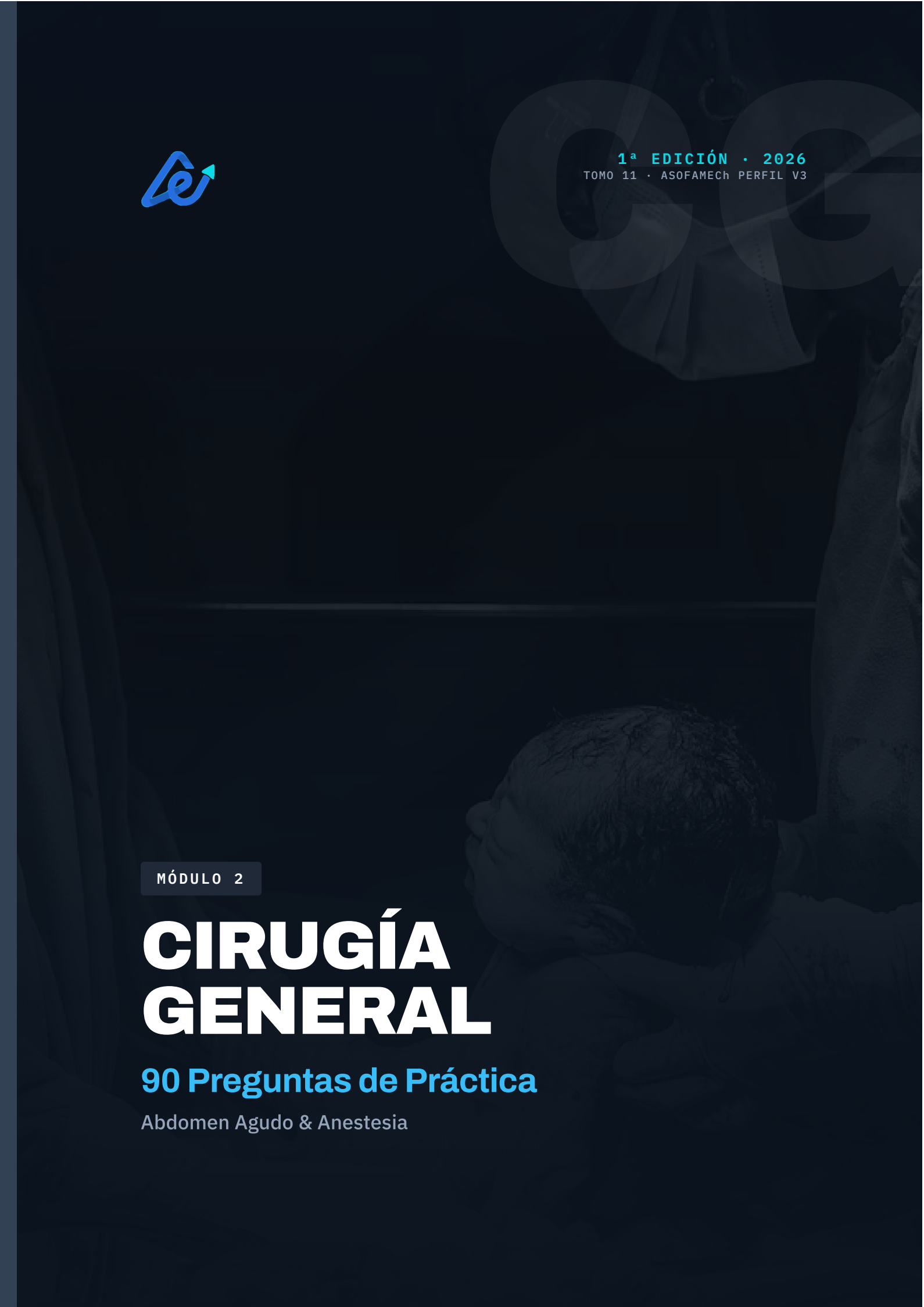
**Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor**

1.07.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Control ambulatorio GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor, la conducta médica prioritaria es: La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 11 · ASOFAMECh PERFIL V3



MÓDULO 2

# CIRUGÍA GENERAL

## 90 Preguntas de Práctica

Abdomen Agudo & Anestesia

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Cirugía General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO** | | | | | |
| 4.01.1.002 | Divertículos esofágicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.005 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q8 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.008 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.014 | Pólipos de colon y recto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.015 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q10 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.019 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.025 | Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.028 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.030 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q13 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.031 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q14 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.033 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q15 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.035 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.037 | Hidatidosis pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.039 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.040 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q18 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.044 | Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.045 | Enfermedad renovascular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q5 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| 4.01.1.049 | Trombosis venosa profunda y tromboflebitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO** | | | | | |
| 4.01.1.001 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 4.01.1.003 | Divertículo de Meckel | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.006 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q22 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.007 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q32 | Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5) |
| 4.01.1.009 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.011 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q25 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.016 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q26 | Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30) |
| 4.01.1.017 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27 | Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30) |
| 4.01.1.018 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.01.1.020 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q28 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.021 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q23 | Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26) |
| 4.01.1.022 | Hidatidosis hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.023 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q29 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.024 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q35 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.032 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.034 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q30 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | | | | |
| 4.01.1.036 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q31 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.038 | Nódulo pulmonar solitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)** | | | | | |
| 4.01.1.004 | Acalasia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.026 | Ictericia obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 11 · C.13 (Pág. 30) |
| 4.01.1.041 | Síndromes mediastínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.046 | Insuficiencia cerebro vascular | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.050 | Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.051 | Pie diabético | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.053 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.01.1.054 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q53 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.055 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.056 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.058 | Condilomas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.059 | Onicocriptosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q44 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.060 | Obesidad mórbida | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.002 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.01.2.003 | Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.005 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49 | Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17) |
| 4.01.2.006 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47 | Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5) |
| 4.01.2.007 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)** | | | | | |
| 4.01.1.012 | Megacolon | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.027 | Litiasis biliar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.042 | Mesotelioma pleural | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.047 | Insuficiencia arterial crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.052 | Escaras | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q59 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.001 | Esofagitis cáustica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.008 | Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13) |
| 4.01.2.009 | Prolapso rectal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.010 | Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68 | Tomo 11 · 11.11 (Pág. 45) |
| 4.01.2.011 | Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.012 | Colangitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q62 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.013 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.015 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.016 | Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 11 · 11.10 (Pág. 41) |
| 4.01.2.017 | Supuración pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.018 | Hemoptisis masiva | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q64 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| 4.01.2.020 | Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24) |
| 4.01.2.021 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q67 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS** | | | | | |
| 4.01.1.013 | Enfermedad diverticular no complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.029 | Pancreatitis crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.043 | Síndrome de ocupación pleural | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.048 | Várices. Insuficiencia venosa crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.057 | Cicatrices viciosas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.004 | Hemorragia digestiva alta | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q78 | Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56) |
| 4.01.2.014 | Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.019 | Perforación esofágica - Mediastinitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q79 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.022 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.023 | Traumatismos vasculares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.024 | Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.025 | Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q88 | Tomo 11 · C.3 (Pág. 10) |
| 4.01.2.026 | Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84 | Tomo 11 · 11.13 (Pág. 53) |
| 4.01.2.027 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q90 | Tomo 11 · 11.9 (Pág. 37) |
| 4.01.2.028 | Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 11 · 11.15 (Pág. 62) |
| 4.01.2.029 | Septicemia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q81 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.030 | Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: | — | Q83 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Laparotomía de Urgencia** | **Derivar** | | | |
| 4.01.2.031 | **Shock** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q82 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Cirugía General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.1.001 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 4.01.1.002 | Divertículos esofágicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.003 | Divertículo de Meckel | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.004 | Acalasia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.005 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q8 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.006 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q22 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.007 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q32 | Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5) |
| 4.01.1.008 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.009 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.011 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q25 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.012 | Megacolon | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.013 | Enfermedad diverticular no complicada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.014 | Pólipos de colon y recto | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.015 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q10 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.016 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q26 | Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30) |
| 4.01.1.017 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27 | Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.1.018 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.01.1.019 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.020 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q28 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.021 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q23 | Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26) |
| 4.01.1.022 | Hidatidosis hepática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.023 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q29 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.024 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q35 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.025 | Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.026 | Ictericia obstructiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 11 · C.13 (Pág. 30) |
| 4.01.1.027 | Litiasis biliar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.028 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.029 | Pancreatitis crónica | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.030 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q13 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.031 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q14 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.032 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.033 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q15 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.034 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q30 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.035 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.036 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: | GES | Q31 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | **Completo** | | | |
| 4.01.1.037 | Hidatidosis pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.038 | Nódulo pulmonar solitario | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.039 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.040 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q18 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.041 | Síndromes mediastínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.042 | Mesotelioma pleural | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.043 | Síndrome de ocupación pleural | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q75 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.044 | Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.045 | Enfermedad renovascular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.046 | Insuficiencia cerebro vascular | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.047 | Insuficiencia arterial crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.048 | Várices. Insuficiencia venosa crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.049 | Trombosis venosa profunda y tromboflebitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.050 | Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.051 | Pie diabético | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.052 | Escaras | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q59 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.053 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.01.1.054 | Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q53 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.1.055 | Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.056 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q54 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.057 | Cicatrices viciosas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.058 | Condilomas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.059 | Onicocriptosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q44 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.1.060 | Obesidad mórbida | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.001 | Esofagitis cáustica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.002 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.01.2.003 | Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21) |
| 4.01.2.004 | Hemorragia digestiva alta | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q78 | Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56) |
| 4.01.2.005 | Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49 | Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17) |
| 4.01.2.006 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q47 | Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5) |
| 4.01.2.007 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.008 | Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13) |
| 4.01.2.009 | Prolapso rectal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.010 | Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68 | Tomo 11 · 11.11 (Pág. 45) |
| 4.01.2.011 | Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.012 | Colangitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q62 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.013 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.014 | Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.015 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.016 | Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 11 · 11.10 (Pág. 41) |
| 4.01.2.017 | Supuración pulmonar | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.018 | Hemoptisis masiva | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q64 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.019 | Perforación esofágica - Mediastinitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q79 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.020 | Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24) |
| 4.01.2.021 | Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q67 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.022 | Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.023 | Traumatismos vasculares | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.024 | Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.025 | Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q88 | Tomo 11 · C.3 (Pág. 10) |
| 4.01.2.026 | Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q84 | Tomo 11 · 11.13 (Pág. 53) |
| 4.01.2.027 | Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q90 | Tomo 11 · 11.9 (Pág. 37) |
| 4.01.2.028 | Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85 | Tomo 11 · 11.15 (Pág. 62) |
| 4.01.2.029 | Septicemia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q81 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.030 | Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q83 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |
| 4.01.2.031 | Shock | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q82 | Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

PREGUNTA 1 4.01.1.002

**1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículos esofágicos · 4.01.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículos esofágicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 4.01.1.014

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pólipos de colon y recto · 4.01.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pólipos de colon y recto. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 4.01.1.037

**3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis pulmonar · 4.01.1.037] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 4.01.1.044

**4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea · 4.01.1.044] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 5 4.01.1.045

**5. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad renovascular · 4.01.1.045] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad renovascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 4.01.1.049

**6. Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al examen físico destaca pálida, frecuencia cardiaca de 110 por minuto y con presión arterial de 90/60. El diagnóstico más probable es:**

A) Atelectasia
B) Reacción adversa a medicamentos
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infección de herida operatoria
E) Hemoperitoneo

PREGUNTA 7 4.01.1.025

**7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Colecistitis crónica · 4.01.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Colecistitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 4.01.1.005

**8. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del esofágo · 4.01.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del esofágo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 9 4.01.1.008

**9. Un paciente de con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por cuadro de vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, con ausencia de grasa y con edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Instalar sonda nasogástrica
B) Indicar nutrición parenteral total
C) Realizar radioterapia de urgencia
D) Realizar gastrectomía paliativa
E) Realizar derivación gastrointestinal

PREGUNTA 10 4.01.1.015

**10. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer colorectal · 4.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer colorectal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 11 4.01.1.019

**11.** **Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los margenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:**

A) Hemorroide externa trombosado
B) Condiloma acuminado
C) Sífilis
D) Cáncer epidermoide
E) Enfermedad de Cröhn

PREGUNTA 12 4.01.1.028

**12.** **Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una colelitiasis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicta un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?**

A) Quimioterapia
B) Radioterapia
C) Cuidados paliativo
D) Control con TAC cada 3 meses
E) Colecistectomía radical

PREGUNTA 13 4.01.1.030

**13.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares · 4.01.1.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 14 4.01.1.031

**14.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas · 4.01.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 4.01.1.033

**15.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del tiroides · 4.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.01.1.035

**16.** **Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hidrosadenitis
B) Cáncer de mama
C) Cáncer de pulmón
D) Lipoma
E) Tuberculosis ganglionar

PREGUNTA 17 4.01.1.039

**17. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer pulmonar · 4.01.1.039] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 4.01.1.040

**18. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas · 4.01.1.040] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

## BLOQUE 2 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

PREGUNTA 19 4.01.1.003

**19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículo de Meckel · 4.01.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículo de Meckel. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 4.01.1.022

**20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis hepática · 4.01.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis hepática. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 4.01.1.038

**21. [ATENCIÓN PRIMARIA: Nódulo pulmonar solitario · 4.01.1.038] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Nódulo pulmonar solitario. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 22 4.01.1.006

**22. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernia hiatal · 4.01.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernia hiatal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 23 4.01.1.021

**23. Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma
B) Hernia inguinal
C) Adenopatía metastásica
D) Hernia femoral
E) Sarcoma de partes blandas

PREGUNTA 24 4.01.1.001

**24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Patología glándulas salivales · 4.01.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología glándulas salivales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 4.01.1.011

**25. [ATENCIÓN PRIMARIA: Fístulas del intestino delgado · 4.01.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Fístulas del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 26 4.01.1.016

**26. Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Hemorroidectomía de urgencia
B) Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local
C) Ligadura con banda elástica
D) Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento
E) Escleroterapia

PREGUNTA 27 4.01.1.017

**27. Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:**

A) Curación plana
B) Drenaje quirúrgico
C) Antibióticos orales
D) Punción y drenaje
E) Analgésicos

PREGUNTA 28 4.01.1.020

**28. Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persis- tiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroide externo trombosado
B) Cáncer de recto
C) Fisura anal
D) Fístula anal
E) Absceso perianal

PREGUNTA 29 4.01.1.023

**29. [ATENCIÓN PRIMARIA: Quistes y abscesos hepáticos · 4.01.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Quistes y abscesos hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 30 4.01.1.034

**30. [ATENCIÓN PRIMARIA: Patología benigna del tiroides · 4.01.1.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología benigna del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 31 4.01.1.036

**31. Un paciente de 35 años presenta un nódulo mamario, desde hace 8 meses. Su ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior y con un índice ultrasonográfico Birrads 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mastopatía fibroquística
B) Papiloma ductal
C) Fibroadenoma
D) Tumor phylloides
E) Carcinoma ductal

PREGUNTA 32 4.01.1.007

**32. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores gástricos benignos · 4.01.1.007] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores gástricos benignos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 33 4.01.1.009

**33.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores del intestino delgado · 4.01.1.009] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 4.01.1.018

**34.** **Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media, sobre el coxis. Al examen físico, se observa aumento de volumen de 5 cm, doloroso, con presencia de dos orificios negros en la piel, cerca de la lesión. El diagnóstico más probable es:**

A) Linfoma
B) Sarcoma
C) Quiste pilonidal
D) Absceso anorrectal
E) Lipoma

PREGUNTA 35 4.01.1.024

**35.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores hepáticos · 4.01.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 36 4.01.1.032

**36.** **Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Nódulo tiroideo
B) Quiste branquial
C) Quiste tirogloso
D) Linfadenopatía tuberculosa
E) Tumor de glándula salival secundaria

## BLOQUE 3 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

PREGUNTA 37 4.01.1.004

**37.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Acalasia · 4.01.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Acalasia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 4.01.1.026

**38.** **Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:**

A) Litiasis en vía biliar común
B) Lesión vía biliar iatrogénica
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

PREGUNTA 39 4.01.1.041

**39. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mediastínicos · 4.01.1.041] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mediastínicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 40 4.01.1.046

**40. [ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia cerebro vascular · 4.01.1.046] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia cerebro vascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 41 4.01.1.050

**41. Un paciente de 58 años, con antecedente de várices en ambas piernas, de gran tamaño, consulta porque hace dos semanas sufrió un pequeño trauma en su extremidad inferior izquierda, evolucionando con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño, hasta alcanzar 1,5 cm y que se ubica a 2 cm del maléolo interno. Al examen físico, se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, más la presencia de las várices descritas. ¿Cuál es la etiología más probable de su lesión?**

A) Infecciosa
B) Isquémica
C) Venosa
D) Neuropática
E) Por presión

PREGUNTA 42 4.01.1.051

**42. Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer ortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
B) Angiografía
C) Amputación abierta
D) Amputación cerrada
E) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

PREGUNTA 43 4.01.1.058

**43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Condilomas · 4.01.1.058] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Condilomas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 4.01.1.059

**44. [ATENCIÓN PRIMARIA: Onicocriptosis · 4.01.1.059] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Onicocriptosis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 45 4.01.1.060

**45.** **Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. El diagnóstico más probable es:**

A) Hipoglicemias reactivas
B) Síndrome de dumping
C) Hernia del espacio de Petersen
D) Estenosis de la anastomosis
E) Déficit de vitamina B12

PREGUNTA 46 4.01.2.002

**46.** **[URGENCIA: Abdomen agudo · 4.01.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Abdomen agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 4.01.2.006

**47.** **Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:**

A) Pielonefritis aguda
B) Apendicitis aguda
C) ITU baja
D) Torsión ovárica
E) Plastrón apendicular

PREGUNTA 48 4.01.2.007

**48.** **Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdo- men doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trombosis de la vena mesentérica
B) Hemoperitoneo
C) Úlcera péptica perforada
D) Embolia mesentérica
E) Aneurisma aórtico abdominal roto

PREGUNTA 49 4.01.2.005

**49.** **Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asocia- do a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta do- lor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y to- nalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:**

A) Obstrucción intestinal
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Embolia mesenterica
D) Pancreatitis
E) Diverticulitis

PREGUNTA 50 4.01.2.003

**50.** **Una paciente de 43 años, multípara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 100/60 mmHg y al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea Pfannestiel, y se palpa abdomen muy doloroso tanto a la palpación superficial como profunda, con distensión de la pared abdominal, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Megacolon
E) Embolia mesentérica

PREGUNTA 51 4.01.1.055

**51.** **Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen: FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:**

A) Observar evolución
B) Indicar corticoides tópicos
C) Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico
D) Realizar resección quirúrgica del quiste
E) Puncionar la lesión

PREGUNTA 52 4.01.1.053

**52.** **Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:**

A) Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

PREGUNTA 53 4.01.1.054

**53.** **Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resección y biopsia
B) Observar evolución
C) Solicitar ecografía de partes blandas
D) Solicitar radiografía de fémur
E) Realizar punción y drenaje

PREGUNTA 54 4.01.1.056

**54.** **Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que, desde hace dos años, presenta una úlcera en relación a la cicatriz. Al examen físico se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tratamiento con nitrógeno líquido
B) Aseo quirúrgico
C) Resección amplia
D) Biopsia incisional
E) Curaciones con povidona y suero fisiológico

## BLOQUE 4 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

PREGUNTA 55 4.01.1.012

**55.** **Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable y se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:**

A) TAC abdominal
B) Colonoscopía
C) Test del sudor
D) Biopsia por succión
E) Cariograma

PREGUNTA 56 4.01.1.027

**56.** **Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): El diagnóstico más probable es:**

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colecistitis crónica
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis aguda

PREGUNTA 57 4.01.1.042

**57.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Mesotelioma pleural · 4.01.1.042] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Mesotelioma pleural. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 4.01.1.047

**58.** **Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección?**

A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
B) AngioTAC de extremidades inferiores
C) Arteriografía de extremidades inferiores
D) Doppler venoso de extremidades inferiores
E) Índice tobillo-brazo (ITB)

PREGUNTA 59 4.01.1.052

**59. [ATENCIÓN PRIMARIA: Escaras · 4.01.1.052] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Escaras. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 60 4.01.2.001

**60. [URGENCIA: Esofagitis cáustica · 4.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Esofagitis cáustica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 61 4.01.2.009

**61. [URGENCIA: Prolapso rectal · 4.01.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Prolapso rectal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 62 4.01.2.012

**62. [URGENCIA: Colangitis · 4.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Colangitis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 63 4.01.2.017

**63. [URGENCIA: Supuración pulmonar · 4.01.2.017] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Supuración pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 64 4.01.2.018

**64. [URGENCIA: Hemoptisis masiva · 4.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemoptisis masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 65 4.01.2.013

**65. [URGENCIA: Pancreatitis aguda · 4.01.2.013] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pancreatitis aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 66 4.01.2.016

**66. Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir radiografía de tórax
B) Pedir resonancia magnética de tórax
C) Instalar un tubo pleural
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar videotoracoscopía

PREGUNTA 67 4.01.2.021

**67. [URGENCIA: Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos · 4.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 68 4.01.2.010

**68. Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
B) Realizar ecografía fast
C) Suturar la herida
D) Solicitar TAC abdominal
E) Realizar laparoscopía exploradora

PREGUNTA 69 4.01.2.020

**69. [URGENCIA: Traumatismo raquimedular · 4.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo raquimedular. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 70 4.01.2.011

**70. Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Estable hemodinámicamente, fiebre 38°C, leucocitos 14.000. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?**

A) Colecistectomía laparoscópica precoz (dentro de 72h)
B) Cirugía electiva en 6 semanas
C) Drenaje percutáneo y cirugía diferida
D) Solo ATB EV y observación
E) Colecistostomía abierta de urgencia

PREGUNTA 71 4.01.2.008

**71. Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Cáncer de colon
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Hernia inguinal complicada

PREGUNTA 72 4.01.2.015

**72.** **[URGENCIA: Trauma maxilofacial · 4.01.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma maxilofacial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

## BLOQUE 5 PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

PREGUNTA 73 4.01.1.013

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad diverticular no complicada · 4.01.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad diverticular no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 4.01.1.029

**74.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Pancreatitis crónica · 4.01.1.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pancreatitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 4.01.1.043

**75.** **Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Foto 13 (https://imgur.com/gallery/U6p0b/comment/113820836) (La foto fue ennegrecida, para que se pareciera a las del Eunacom real, impreso). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control radiológico en 24 horas

B) Solicitar TAC de tórax

C) Realizar cirugía abierta

D) Drenaje con tubo pleural

E) Videotoracoscopía

PREGUNTA 76 4.01.1.048

**76.** **Mujer de 45 años con várices en extremidades inferiores bilaterales, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Anticoagulación oral
B) Flebectomía inmediata
C) Escleroterapia de urgencia
D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas
E) Derivación vascular urgente

PREGUNTA 77 4.01.1.057

**77.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cicatrices viciosas · 4.01.1.057] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cicatrices viciosas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 78 4.01.2.004

**78.** **[URGENCIA: Hemorragia digestiva alta · 4.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemorragia digestiva alta. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 79 4.01.2.019

**79.** **Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopía digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor toráxico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:**

A) Radiografía de tórax
B) Repetir endoscopía
C) Tomografía axial computada de tórax
D) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
E) Electrocardiograma

PREGUNTA 80 4.01.2.023

**80.** **[URGENCIA: Traumatismos vasculares · 4.01.2.023] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismos vasculares. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 81 4.01.2.029

**81.** **[URGENCIA: Septicemia · 4.01.2.029] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Septicemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 82 4.01.2.031

**82. [URGENCIA: Shock · 4.01.2.031] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Shock. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 83 4.01.2.030

**83. [URGENCIA: Paro cardiorespiratorio · 4.01.2.030] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 84 4.01.2.026

**84. Niño con quemadura en palmas y dedos, eritema importante y ampollas, inquieto e irritable en urgencias. ¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Aplicar apósitos de plata y hospitalizar

B) Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril

C) Indicar analgesia endovenosa

D) Hospitalizar para manejo de quemaduras

E) Debridación bajo anestesia general inmediata

PREGUNTA 85 4.01.2.028

**85. Una mujer de 28 años, trabajadora del área de la salud, es encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa. Al examen físico, está comprometida de conciencia, tiene frecuencia cardíaca de 60 por minuto, frecuencia respiratoria de 8 por minuto y se observan pupilas mióticas, sin focalidad neurológica. ¿Qué tipo de fármaco es el responsable del cuadro de intoxicación de esta paciente?**

A) Benzodiacepinas

B) Barbitúricos

C) Antidepresivos tricíclicos

D) Opioides

E) Hipoglicemiantes

PREGUNTA 86 4.01.2.024

**86. Un paciente, apendictomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su presión arterial es 90/50 mmHg. En el examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:**

A) Hemoperitoneo

B) Evisceración

C) Trombosis de la vena porta

D) Dehiscencia de la base apendicular

E) Tromboembolismo pulmonar masivo

PREGUNTA 87 4.01.2.014

**87. Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Afrontamiento con cianoacrilato

B) Afrontamiento con tela adhesiva

C) Sutura con punto separado

D) Sutura intradérmica

E) Dejar que cure por segunda intención

PREGUNTA 88 4.01.2.025

**88. [URGENCIA: Heridas y contusiones menores · 4.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas y contusiones menores. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 89 4.01.2.022

**89.** **Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión ar- terial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

**A)** Trombosis mesentérica

**B)** Tumor de colon

**C)** Tumor de páncreas

**D)** Disección aórtica

**E)** Aneurisma aórtico abdominal

PREGUNTA 90 4.01.2.027

**90.** **[URGENCIA: Trauma · 4.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

**A)** Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

**B)** Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

**C)** Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

**D)** Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

**E)** Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A Divertículos esofágicos

4.01.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículos esofágicos" (4.01.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A Pólipos de colon y recto

4.01.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pólipos de colon y recto" (4.01.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A Hidatidosis pulmonar

4.01.1.037 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis pulmonar" (4.01.1.037), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

**Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea**

4.01.1.044 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea" (4.01.1.044), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 5 Respuesta: A Enfermedad renovascular

4.01.1.045 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad renovascular" (4.01.1.045), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 6 Respuesta: C

**Trombosis venosa profunda y tromboflebitis**

4.01.1.049 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por ser postQx es TEP y por el compromiso HDN es masivo probblemente

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A**

4.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Colecistitis crónica" (4.01.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: A**

4.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del esofágo" (4.01.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: E**

4.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La derivación gastroyeyunal es menos agresiva que la hgastrectomía y permite retablecer el tránsito gastrointestinal.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

4.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer colorectal" (4.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: D**

4.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

Es un cáncer de recto, que aumenta el riesgo en el paciente VIH, en especial con VPH de alto riesgo (serotipos 16 y 18).

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: E**

4.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

Lo correcto es hacer una cirugía abierta, con cuña hepática y linfadenectomía y no una colecistectomía radical, ya que la vesícula ya se extirpó. Sin embargo, de las alternativas que había, era la más aceptable.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: A**

4.01.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares" (4.01.1.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

4.01.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas" (4.01.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

4.01.1.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del tiroides" (4.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

4.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

El cáncer de mama es el que da metástasis gangionares a la axila con mayor frecuencia. Que sea indolora descarta hidrosadenitis. Lipoma es blando. TBC ganglionar es rara y suele tener una clínica más inflamatoria, con fistulización: sale caseum.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

4.01.1.039 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer pulmonar" (4.01.1.039), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: A**

4.01.1.040 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas" (4.01.1.040), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

## BLOQUE 2 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A** **Divertículo de Meckel** 4.01.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículo de Meckel" (4.01.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A** **Hidatidosis hepática** 4.01.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis hepática" (4.01.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A** **Nódulo pulmonar solitario** 4.01.1.038 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Nódulo pulmonar solitario" (4.01.1.038), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

4.01.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernia hiatal" (4.01.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: D**

**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

4.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: A**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología glándulas salivales" (4.01.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Fístulas del intestino delgado" (4.01.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Hemorroides externas trombosadas en primeras 72h: trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor en forma inmediata. Después de 72h, el manejo es conservador pues el trombo se reabsorbe.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Probable absceso perianal. Debe ser drenado en pabellón.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: C**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Fisura anal clásica.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: A**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Quistes y abscesos hepáticos" (4.01.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.034 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología benigna del tiroides" (4.01.1.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: C**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.036 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un fibroadenoma clásico. Se sigue con ecografía cada 6 meses por 2 años. Se ve sólido, hipoecogénico, con bordes bien definidos, habitualmente con forma oval y orientación horizontal. Suele no tener sombra ni refuerzo posterior.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores gástricos benignos" (4.01.1.007), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: A**

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores del intestino delgado" (4.01.1.009), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: C**

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 43). Evalúa el manejo clínico de Enfermedades del seno pilonidal según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: A**

4.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores hepáticos" (4.01.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

4.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

---

## BLOQUE 3 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Acalasia** 4.01.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Acalasia" (4.01.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: B** **Ictericia obstructiva** 4.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 161). Evalúa el manejo clínico de Ictericia obstructiva según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A** **Síndromes mediastínicos** 4.01.1.041 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mediastínicos" (4.01.1.041), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: A** **Insuficiencia cerebro vascular** 4.01.1.046 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia cerebro vascular" (4.01.1.046), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: C**

4.01.1.050 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)**

Úlcera venosa: Las úlceras venosas suelen ser poco dolorosas o incluso indoloras. Se ubican generalmente en el maléolo interno y se asocian al síndrome postflebítico, que se caracteriza por hiperpigmentación de la piel. En contraste, las úlceras arteriales son dolorosas y se ubican con mayor frecuencia en el maléolo externo, los ortejos o los talones. El fondo de las úlceras arteriales es isquémico, de color pálido o blanco, mientras que el fondo de las úlceras venosas es hiperémico y violáceo.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: E** Pie diabético

4.01.1.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una fasceítis necrotizante, sin compromiso óseo (no amputar). Si tuviera la osteomielitis, se amputa el pie diabético.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A** Condilomas

4.01.1.058 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Condilomas" (4.01.1.058), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A** Onicocriptosis

4.01.1.059 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Onicocriptosis" (4.01.1.059), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B** Obesidad mórbida

4.01.1.060 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un síndrome de dumping clásico (aprender dicha clínica), frecuente complicación de un by-pass gástrico. Se caracteriza por síntomas disautonómicos, que pueden ser muy similares a una hipoglicemia, por lo que siempre se debe solicitar HGT para descartarla. Sin embargo, la diarrea no calza con hipoglicemia, sino solo con dumping.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A**

**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Abdomen agudo" como urgencia clínica (4.01.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

4.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una apendicitis clásica.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: D**

**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

4.01.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen di- chos signos.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: A**

**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

4.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: C**

**Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)**

4.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La pérdida de la matidez hepática sugiere un neumoperitoneo, secundario a una perforación. También tiene clínica de la peritonitis secundaria: abolición de RHA, dolor intenso.

**PREGUNTA 51** **Respuesta: C**

**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.055 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un quiste epidérmico abscedado, lo que se trata con antibióticos (antiestafilocócicos: ej. cloxacilina) más drenaje quirúrgico. Eventualmente, el quiste sí se debe resecar, pero no mientras está infectado.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: A**

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.053 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 79). Evalúa el manejo clínico de Tumores benignos de partes blandas según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 53** **Respuesta: C**

**Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.054 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un probable sarcoma de partes blandas. Debe estudiarse con resonancia magnética nuclear, como examen de elección, para determinar el grado de invasión, antes de definir qué tipo de cirugía se le hará. Como no aparecía en las opciones, lo más razonable es hacer la ecografía, porque al menos es suficiente para distinguir entre un tumor benigno y uno maligno. Luego sí se hará la resección y biopsia.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: D**

**Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)**

4.01.1.056 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una úlcera de Majorlin, que es un tipo de carcinoma espinocelular de muy lento crecimiento, que aparece en cicatrices de grandes quemaduras. Su diagnóstico es la biopsia incisional o con una biopsia "punch" y luego de confirmar la histología, se procede a la excisión completa y manejo oncológico. En ocasiones, el carcinoma solo está en una zona del borde de la úlcera, por lo que se recomienda varias biopsias incisionales. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben y sea como sea, tenía "pinta" de cáncer, así que a biopsiarlo.

## BLOQUE 4 POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: D** **Megacolon**

4.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Se sospecha una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con la biopsia intestinal, que muestra aganglionosis del plexo submucoso o mientérico, en el segmento afectado.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A** **Litiasis biliar**

4.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una imagen de cálculos con la sombra acústica clásica. Se debe programar cirugía electiva.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A** **Mesotelioma pleural**

4.01.1.042 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Mesotelioma pleural" (4.01.1.042), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: E** **Insuficiencia arterial crónica** `4.01.1.047` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

Índice tobillo-brazo (ITB)

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A** **Escaras** `4.01.1.052` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo`

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Escaras" (4.01.1.052), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A** **Esofagitis cáustica** `4.01.2.001` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Esofagitis cáustica" como urgencia clínica (4.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A** **Prolapso rectal** `4.01.2.009` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Prolapso rectal" como urgencia clínica (4.01.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A** **Colangitis** `4.01.2.012` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Colangitis" como urgencia clínica (4.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A** **Supuración pulmonar** `4.01.2.017` `Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Supuración pulmonar" como urgencia clínica (4.01.2.017), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A** **Hemoptisis masiva** `4.01.2.018` `Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemoptisis masiva" como urgencia clínica (4.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: A**

`4.01.2.013` `Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar`

**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pancreatitis aguda" como urgencia clínica (4.01.2.013), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: A**

4.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante**

Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

4.01.2.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos" como urgencia clínica (4.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: E**

4.01.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia**

Tiene una herida penetrante abdominal (lacera el peritoneo). La mayoría de los autores recomienda explorar, idealmente por laparoscopía. De todos modos algunos recomiendan hacer EcoFast si está en tan buenas condiciones y tiene buena evolución (como es este caso). No es un tema cerrado, sino controvertido.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

4.01.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo raquimedular" como urgencia clínica (4.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

4.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap**

Colecistitis aguda no complicada: colecistectomía laparoscópica precoz (<72h del diagnóstico) es superior al manejo diferido. Menor complicaciones, estadía hospitalaria y conversión a cirugía abierta.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: D**

4.01.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx**

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

4.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma maxilofacial" como urgencia clínica (4.01.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A**

**Enfermedad diverticular no complicada**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad diverticular no complicada" (4.01.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Pancreatitis crónica** 4.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pancreatitis crónica" (4.01.1.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: D** **Síndrome de ocupación pleural** 4.01.1.043 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la clínica era un neumotórax. La radiografía era muy oscura, pero con imaginación y paciencia, se veía el neumotórax derecho (acá se ve más que en el real). Por ser mayor a 15%, se trata con tubo pleural.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: D**

**Várices. Insuficiencia venosa crónica**

4.01.1.048 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Varices simples sin complicaciones: manejo inicial conservador con elevación de extremidades, ejercicio (caminata), control de peso y medias de compresión elástica. La cirugía/escleroterapia se reserva para cuando las medidas conservadoras fallan o hay complicaciones.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A** **Cicatrices viciosas** 4.01.1.057 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cicatrices viciosas" (4.01.1.057), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A** **Hemorragia digestiva alta** 4.01.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemorragia digestiva alta" como urgencia clínica (4.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: C** **Perforación esofágica - Mediastinitis** 4.01.2.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sospecha de perforación esofágica iatrogénica, con mediastinitis secundaria. El TAC es el mejor examen.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A** **Traumatismos vasculares** 4.01.2.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismos vasculares" como urgencia clínica (4.01.2.023), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A** Septicemia

4.01.2.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Septicemia" como urgencia clínica (4.01.2.029), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A** Shock

4.01.2.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Shock" como urgencia clínica (4.01.2.031), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia**

4.01.2.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorespiratorio" como urgencia clínica (4.01.2.030), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: C**

**Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES**

4.01.2.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Indicar analgesia endovenosa

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: D**

**Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales**

4.01.2.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome Opioide: Este síndrome se caracteriza por compromiso de la conciencia, depresión respiratoria y miosis puntiforme (pupilas contraídas). Es importante diferenciarlo de otros síndromes: el síndrome por benzodiazepinas también presenta compromiso de conciencia y depresión respiratoria, pero sin alteración pupilar significativa; los síndromes adrenérgico y anticolinérgico causan midriasis (pupilas dilatadas); y el síndrome colinérgico, al igual que el opioide, se caracteriza por miosis (pupilas contraídas).

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A**

**Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)**

4.01.2.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

[Pregunta disputada] Es una pregunta difícil, ya que el compromiso hemodinámico y los signos peritoneales pueden corresponder tanto a un hemoperitoneo, como a la dehiscencia de la base apendicular. Sin embargo, por predominar el compromiso hemodinámico, nos inclinamos a marcar hemoperitoneo. Si, en cambio, hubiese tenido predominancia de los signos peritoneales, nos habríamos inclinado a la dehiscencia.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: D**

**Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica**

4.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica**

4.01.2.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas y contusiones menores" como urgencia clínica (4.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: E**

**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

4.01.2.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.

---

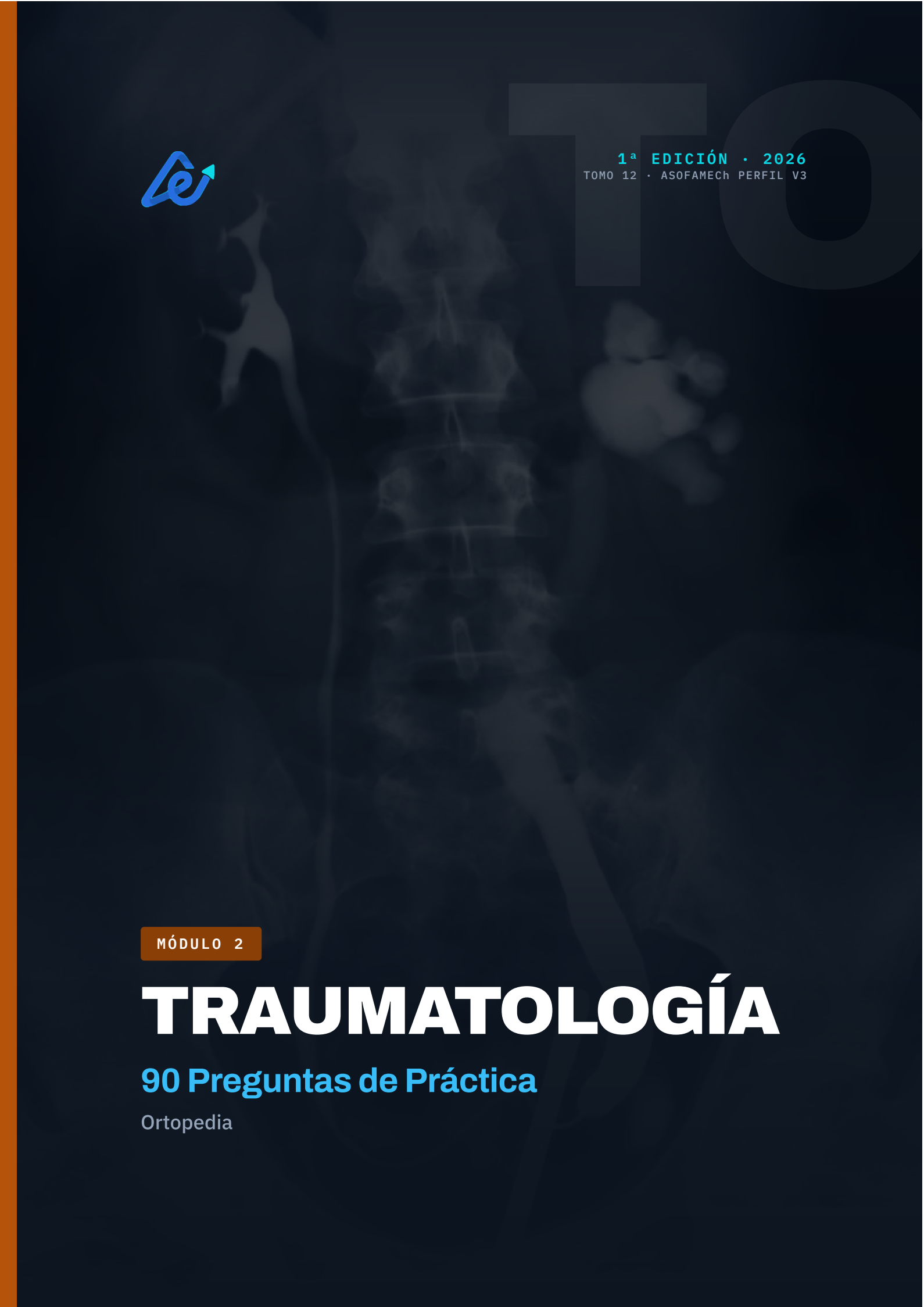
**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)**

4.01.2.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma" como urgencia clínica (4.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---



1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 12 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 2

# TRAUMATOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Ortopedia

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Traumatología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 12 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES** | | | | | |
| 1.01.1.006 | Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16, Q17 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.12.2.001 | Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q11, Q12, Q13 | Tomo 12 · 12.2 (Pág. 7) |
| 4.01.1.001 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial y Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3, Q4 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 4.02.1.003 | Escoliosis y deformidades vertebrales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.008 | Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.001 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.002 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q6 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.005 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.007 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.008 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.009 | Heridas de la mano no complicadas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES** | | | | | |
| 1.01.2.007 | Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 01 · 3.3 (Pág. 33) |
| 4.01.2.020 | Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32, Q33, Q34, Q35 | Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24) |
| 4.02.1.001 | Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q23, Q24, Q25, Q26 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.1.004 | Infecciones osteoarticulares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.006 | Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.014 | Politraumatizado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.015 | Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA** | | | | | |
| 1.01.1.021 | Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q43, Q44 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.14.1.001 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40 | Tomo 12 · 12.7 (Pág. 31) |
| 4.02.1.006 | Lumbociática radicular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37, Q38 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.004 | Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 12 · 12.9 (Pág. 35) |
| 4.02.2.010 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q41 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.012 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q42 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.013 | Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q45 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA** | | | | | |
| 1.01.1.021 | Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q63, Q64, Q65 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.08.1.001 | Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q70, Q71, Q72 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 4.02.1.007 | Pie plano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57, Q58 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.011 | Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66, Q67, Q68, Q69 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 8.01.1.003 | Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA | Dx: **Específico** Tx: **Inicial y** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62 | Tomo 12 · 12.10 (Pág. 39) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda | **Completo** · Seg: **Completo** | | | |
| **BLOQUE 5: ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA** | | | | | |
| 1.08.1.001 | Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q74, Q75, Q76, Q77 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 1.10.1.001 | Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86, Q87, Q88 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 4.02.1.002 | Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q78, Q79, Q80 | Tomo 12 · C.6 (Pág. 16) |
| 4.02.1.005 | Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.009 | Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 12 · 12.14 (Pág. 52) |
| 4.02.2.003 | Esguince grado1 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Traumatología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 12 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.006 | Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14, Q15, Q16, Q17 | Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29) |
| 1.01.1.021 | Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q43, Q44, Q63, Q64, Q65 | Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57) |
| 1.01.2.007 | Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q27, Q28, Q29, Q30 | Tomo 01 · 3.3 (Pág. 33) |
| 1.08.1.001 | Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q70, Q71, Q72, Q74, Q75, Q76, Q77 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 1.10.1.001 | Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86, Q87, Q88 | Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26) |
| 1.12.2.001 | Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10, Q11, Q12, Q13 | Tomo 12 · 12.2 (Pág. 7) |
| 1.14.1.001 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40 | Tomo 12 · 12.7 (Pág. 31) |
| 4.01.1.001 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial y Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3, Q4 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 4.01.2.020 | Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32, Q33, Q34, Q35 | Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24) |
| 4.02.1.001 | Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q23, Q24, Q25, Q26 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.002 | Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q78, Q79, Q80 | Tomo 12 · C.6 (Pág. 16) |
| 4.02.1.003 | Escoliosis y deformidades vertebrales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.004 | Infecciones osteoarticulares | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.005 | Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica) | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.006 | Lumbociática radicular | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q37, Q38 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| 4.02.1.007 | Pie plano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55, Q56, Q57, Q58 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.008 | Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.1.009 | Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 12 · 12.14 (Pág. 52) |
| 4.02.2.001 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.002 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q6 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.003 | Esguince grado1 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.004 | Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 12 · 12.9 (Pág. 35) |
| 4.02.2.005 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.006 | Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.007 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.008 | Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.009 | Heridas de la mano no complicadas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.010 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q41 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.011 | Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66, Q67, Q68, Q69 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.012 | Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q42 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.013 | Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q45 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 4.02.2.014 | Politraumatizado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.2.015 | **Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular** | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8) |
| 8.01.1.003 | **Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial y Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62 | Tomo 12 · 12.10 (Pág. 39) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

PREGUNTA 1 4.02.1.003

**1. Una paciente de 63 años presenta dolor dorsal intenso, que inició hace 5 días, en relación a un esfuerzo en flexión y que ha aumentado, limitando significativamente sus actividades de la vida diaria. Tiene antecedente de una fractura de muñeca hace un año, que requirió tratamiento quirúrgico. Al examen físico se aprecia adolorida, con signos vitales normales, dolor a la movilización activa y pasiva de su columna dorsal, que limita los movimientos de flexo-extensión. A la inspección la curvatura dorsal se observa redonda, sin cifosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hernia del núcleo pulposo
B) Tuberculosis vertebral
C) Espondilolistesis dorsal
D) Espondilosis dorsal
E) Fractura vertebral

PREGUNTA 2 4.02.2.009

**2. [URGENCIA: Heridas de la mano no complicadas · 4.02.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas de la mano no complicadas. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 3 4.01.1.001

**3. Un hombre de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A) Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas
B) Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral
C) Luxación de codo; TAC de antebrazo
D) Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior
E) Contusión grave; solo analgesia y observación

PREGUNTA 4 4.01.1.001

**4. Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con múltiples fragmentos conminutos. ¿Cuál es la conducta?**

A) Inmovilización con yeso e indicar control en dos semanas
B) Cirugía con reducción y osteosíntesis
C) Tracción continua por cuatro semanas y luego yeso
D) Observación porque las fracturas de pierna siempre consolidan solas
E) Inmovilización con órtesis funcional por seis semanas

PREGUNTA 5 4.02.2.001

**5. Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:**

A) Trombosis venosa profunda
B) Síndrome compartimental
C) Distrofia simpático refleja
D) Alergia al yeso
E) Síndrome de túne carpiano agudo

PREGUNTA 6 4.02.2.002

**6. Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: El diagnóstico es:**

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello del fémur
D) Luxacion de la Cadera izquierda
E) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

PREGUNTA 7 4.02.2.005

**7. Un paciente de 70 años, sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Consulta al día siguiente, con la muñeca deformada en "dorso de tenedor" y presencia de equimosis en la zona palmar y en la zona dorsal. Presenta dolor a la compresión de la zona distal del radio. EL diagnóstico más probable es:**

A) Esguince de muñeca
B) Fractura de la epífisis distal del radio
C) Disyunción del extremo distal del radio
D) Luxofractura de Monteggia
E) Fractura de escafoides carpiano

PREGUNTA 8 4.02.2.007

**8. Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de hombro, una de las que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía AP de hombro, con fractura del tercio medio de la clavícula derecha, con ligero desplazamiento, sin conminución) ¿Qué tipo de inmovilización es la más adecuada?**

A) Vendaje axial de hombro
B) Vendaje en ocho
C) Yeso Velpeau
D) Yeso toracobraquial
E) Cabestrillo

PREGUNTA 9 4.02.2.008

**9. [URGENCIA: Fracturas expuestas · 4.02.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Fracturas expuestas. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 10 1.12.2.001

**10. Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. ¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?**

A) Cefazolina
B) Amikacina más cefazolina
C) Cefazolina más amikacina más clindamicina
D) Metronidazol intravenoso
E) Amoxicilina clavulánico oral

PREGUNTA 11 1.12.2.001

**11. Un paciente tiene fractura de pierna expuesta con herida de quince centímetros muy contaminada con restos vegetales. ¿Cuál es la clasificación de Gustilo y el esquema antibiótico?**

A) Grado 2; cefazolina más amikacina
B) Grado 3; cefazolina más amikacina más clindamicina
C) Grado 1; solo cefazolina
D) Grado 3; solo metronidazol
E) Grado 2; solo cefazolina

PREGUNTA 12 1.12.2.001

**12. Un médico general maneja una fractura expuesta y va a trasladar al paciente al centro de referencia. ¿Cuál es la forma correcta de inmovilizar y preparar el traslado?**

A) Suturar la herida completamente y colocar yeso circular
B) Cubrir con apósitos estériles e inmovilizar con valva de yeso larga y abierta
C) Dejar la herida al aire sin cubrir y trasladar sin inmovilización
D) Suturar la herida y colocar valva corta de yeso
E) Yeso circular inmediato para asegurar la fractura durante el traslado

PREGUNTA 13 1.12.2.001

**13. En el contexto del manejo de Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 14 1.01.1.006

**14. Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?**

A) Embolia grasa; dímero D
B) Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
C) Tromboembolismo pulmonar; dímero D
D) Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
E) Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

PREGUNTA 15 1.01.1.006

**15. Un paciente operado de fractura de pierna en yeso circular presenta a las cuatro horas un dolor muy intenso en la extremidad que aumenta al mover los ortejos. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?**

A) Distrofia simpático refleja; pregabalina
B) TVP; anticoagulación y ecodoppler
C) Síndrome compartimental; fasciotomía amplia urgente
D) Síndrome compartimental; retirar yeso y observar
E) Dolor postoperatorio normal; analgesia oral

PREGUNTA 16 1.01.1.006

**16. Un paciente con fractura de fémur presenta a las seis horas distrés respiratorio, compromiso de conciencia y se observan petequias en el tronco. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) TEP masivo; trombolisis
B) Embolia grasa; soporte
C) Embolia grasa; anticoagulación con heparina
D) Síndrome compartimental; fasciotomía urgente
E) Distrofia simpático refleja; pregabalina

PREGUNTA 17 1.01.1.006

**17. En el contexto del manejo de Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 18 4.02.1.008

**18. Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita sus actividades, en especial, los movimientos de abducción y elevación. Al examen físico tiene dolor a la palpación subacromial, con dolor a la abducción y elevación del hombro, que dificulta estos movimientos, por sobre 80°. Se solicitan radiografías de hombro, que muestran esclerosis del acromion y leve ascenso de la cabeza humeral. El diagnóstico más probable es:**

A) Tendinitis cálcica
B) Pinzamiento subacromial
C) Rotura completa del tendón del supraespinoso
D) Capsulitis adhesiva
E) Tendinitis bicipital

## BLOQUE 2 GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

PREGUNTA 19 4.02.1.004

**19. Paciente de 67 años, con antecedente de pielonefritis tratada hace dos meses, presenta dolor lumbar desde hace un mes que se ha ido intensificando, asociándose a sensación febril durante los últimos días. Al examen físico presenta temperatura de 38°C y dolor a la palpación de zona lumbar media. Se solicita radiografía lumbar que muestra aplastamiento de L2 y L3, asociados a imagen radiolúcida alrededor del disco intervertebral. El diagnóstico más probable es:**

A) Osteosarcoma
B) Pielonefritis aguda
C) Osteoma osteoide
D) Espondilodiscitis
E) Espondilolistesis

PREGUNTA 20 4.02.2.014

**20. Un niño de 8 años sufre un atropello mientras cruzaba la calle, resultando con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% a aire ambiental. Sus signos vitales muestran taquicardia a 150 la8dos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Además, se observan múl8ples equimosis y, en el examen pulmonar se ausculta asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar izquierdo. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?**

A) Realizar intubación orotraqueal
B) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C) Puncionar el espacio pleural izquierdo
D) Solicitar radiogra:a de tórax
E) Solicitar TAC de tórax

PREGUNTA 21 1.01.2.007

**21. Un paciente sufre fractura de diáfisis humeral en un accidente de tránsito. Al examen físico no puede extender la muñeca ni los dedos. ¿Qué nervio está lesionado y cuál es el déficit sensitivo esperado?**

A) Nervio mediano; hipoestesia de los primeros tres dedos
B) Nervio radial; hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior
C) Nervio cubital; hipoestesia del quinto dedo
D) Nervio axilar; hipoestesia sobre el hombro
E) Nervio ciático; hipoestesia de la pierna

PREGUNTA 22 1.01.2.007

**22. Un paciente sufre luxación anterior de hombro derecho. Al reducirlo presenta imposibilidad de abducir el brazo y disminución de la sensibilidad en la zona deltoidea. ¿Qué nervio está comprometido?**

A) Nervio radial
B) Nervio mediano
C) Nervio axilar o circunflejo
D) Nervio cubital
E) Nervio ciático

PREGUNTA 23 4.02.1.001

**23. Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:**

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

PREGUNTA 24 4.02.1.001

**24. Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:**

A) Necrosis avascular de la cabeza femoral
B) Coxartrosis
C) Hernia foraminal S1
D) Pinzamiento femoroacetabular
E) Estenosis raquimedular

PREGUNTA 25 4.02.1.001

**25. Pregunta 14 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Displasia de caderas
B) Mestástasis óseas
C) Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral
D) Sacroileítis
E) Coxoartrosis bilateral

PREGUNTA 26 4.02.1.001

**26. Una paciente de 30 años, con antecedente de displasia de cadera derecha, tratada con cirugía abierta en su infancia, consulta por dolor muy intenso en la cadera izquier- da, que la hace cojear permanentemente. Al examen físico presenta acortamiento de 25**

A) Tratamiento sintomático de la artrosis
B) Indicar tratamiento kenesioterapéutico
C) Realizar osteotomía acetabular
D) Instalar prótesis total de cadera
E) Compensar el acortamiento con calzado con realce

PREGUNTA 27 1.01.2.007

**27. Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?**

A) Anteroposterior de tórax, anteroposterior de abdomen y lateral de rodilla
B) Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis
C) Anteroposterior de tórax, TAC de cerebro y anteroposterior de pelvis
D) Solo anteroposterior de tórax si el paciente está estable
E) Radiografías de todos los huesos largos más AP de tórax

PREGUNTA 28 1.01.2.007

**28. Un paciente con fractura de pelvis en libro abierto tras un accidente de tránsito está en shock hipovolémico. ¿Cuál es la conducta más urgente para controlar la hemorragia?**

A) Transfusión de glóbulos rojos y esperar que se estabilice solo
B) Cirugía de pelvis de urgencia para clipar las venas pélvicas
C) ABC más estabilización externa de la pelvis con sábana, amaca o tutores externos
D) Instalar sonda Foley para medir diuresis y controlar hidratación
E) Angiografía pélvica para embolizar las arterias sangrantes

PREGUNTA 29 1.01.2.007

**29. Un paciente con fractura de pelvis no puede orinar y presenta dolor suprapúbico. Usted sospecha sección uretral. ¿Cuál es la conducta correcta?**

A) Instalar sonda Foley con cuidado para drenar la vejiga
B) Cistostomía suprapúbica, uretrocistografía y reparación quirúrgica de la uretra
C) Uretrocistografía primero y luego sonda Foley si la uretra está íntegra
D) Observar y esperar que orine espontáneamente
E) TAC de pelvis para ver la extensión de la fractura

PREGUNTA 30 1.01.2.007

**30. En el contexto del manejo de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 31 4.02.2.006

**31. Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación inicial tiene presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardíaca 115x' y se aprecia adolorido. Al examen, además, tiene dolor intenso al comprimir la zona iliaca y púbica y al realizar movimientos de rotación de la pelvis. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Instalar sonda Foley
B) Realizar laparotomía exploradora
C) Realizar radiografía AP de pelvis
D) Instalar sábana pélvica
E) Solicitar TAC de pelvis

PREGUNTA 32 4.01.2.020

**32. Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?**

A) Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
B) Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
C) Consolidación viciosa; cirugía de refractura
D) Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la mala irrigación
E) Osteomielitis; antibióticos endovenosos

PREGUNTA 33 4.01.2.020

**33. Un paciente con fractura de fémur tratada hace seis meses presenta movilidad anormal en el muslo y ausencia de dolor. La radiografía muestra los extremos óseos hipertróficos como pata de elefante con partes blandas interpuestas. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
B) Pseudoartrosis hipertrófica; cirugía para remover partes blandas
C) Consolidación viciosa; refractura quirúrgica
D) Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la irrigación
E) Fractura patológica; descartar tumor óseo

PREGUNTA 34 4.01.2.020

**34. Un paciente con fractura de antebrazo tratada hace tres meses consulta por deformidad del antebrazo sin dolor. La radiografía muestra consolidación completa pero con desviación de los ejes. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Retraso de consolidación; mejorar inmovilización
B) Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
C) Consolidación viciosa; cirugía de refractura con nueva reducción
D) Fractura patológica; estudio de causa subyacente
E) Consolidación normal; alta sin tratamiento

PREGUNTA 35 4.01.2.020

**35. En el contexto del manejo de Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 36 4.02.2.015

**36. Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en flexión. El dolor es intenso, por lo que limita sus actividades de la vida diaria. Al examen físico, se observa dolor a los movimientos de flexoextensión de la columna y se observa tórax encorvado, pero sin cifosis. Su examen neurológico es normal y presenta dolor a la palpación vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Lumbago mecánico
B) Lumbociática mecánica
C) Fractura de cuerpo vertebral
D) Espondiloartrosis lumbar
E) Espondilitis anquilosante

## BLOQUE 3 EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

PREGUNTA 37 4.02.1.006

**37. Un paciente de 60 años consulta por lumbago intenso de 2 semanas de evolución, asociado a disfunción eréc8l, que no ha respondido al tratamiento con analgésicos orales. Al examen Fsico, presenta limitación a los movimientos de flexoextensión y flexión lateral de la columna lumbar, debido al dolor. Además, se obje8va anestesia de la zona perineal. El diagnós8co más probable corresponde a un síndrome:**

A) Lumbociá2ca
B) Facetario lumbar
C) Compresión medular
D) Sacroilíaco
E) De cauda equina

PREGUNTA 38 4.02.1.006

**38. Paciente con antecedente de dolor en espalda, irradiado a glúteos, contractura paravertebral. dolor a la palpación de la columna lumbar y claudicación de la marcha y al estar mucho tiempo de pie, Lasegue negativo, rx de columna lumbar con pinzamiento discal y artrosis lumbar de L3-L4-L5 cuál era:**

A) Claudicación neural intermitente
B) Fractura por compresión
C) Pelviespondilopatía
D) Hernia lumbar
E) Sacroileítis

PREGUNTA 39 1.14.1.001

**39. Un hombre de veintidós años sufre una caída y presenta dolor en la tabaquera anatómica de la mano derecha. La radiografía es normal. ¿Cuál es la conducta?**

A) Alta con analgésicos porque la radiografía es normal y no hay fractura
B) Solicitar TAC de la mano para confirmar o descartar fractura de escafoides
C) Ecografía de partes blandas para evaluar tendones
D) RMN de muñeca como primer examen
E) Inmovilización y control en dos semanas sin más estudios

PREGUNTA 40 1.14.1.001

**40. Un paciente presenta fractura de la diáfisis cubital más luxación de la cúpula radial en la radiografía. ¿Cuál es el nombre de esta lesión?**

A) Fractura de Galeazzi
B) Fractura de Colles
C) Fractura de Monteggia
D) Fractura supracondílea de húmero
E) Fractura subcapital de húmero

PREGUNTA 41 4.02.2.010

**41. Paciente de 35 años sufre traumatismo en la región posterior del húmero. Al examen: no puede extender la muñeca ni los dedos (caída de muñeca). ¿Qué nervio fue lesionado?**

A) Nervio radial (en canal de torsión)
B) Nervio cubital
C) Nervio mediano
D) Nervio musculocutáneo
E) Nervio axilar

PREGUNTA 42 4.02.2.012

**42. Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo que se solicitan radiografías de hombro, que. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reducción cruenta en una semana
B) Inmovilización por 10 días con yeso
C) Artroscopía para reparación del labrum
D) Inmovilización por 7 días con cabestrillo bloqueado
E) Reducción ortopédica de inmediato

PREGUNTA 43 1.01.1.021

**43. Un paciente se tuerce el tobillo y llega a urgencias con dolor, equimosis y dificultad para apoyar el pie. ¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Inmovilizar con yeso y dar de alta sin radiografía porque es clínica de esguince
B) Solicitar radiografía de tobillo para descartar fractura
C) Diagnóstico de esguince; RICE más bota removible sin radiografía
D) TAC de tobillo como primera imagen para ver los ligamentos
E) RMN de tobillo para evaluar los ligamentos laterales

PREGUNTA 44 1.01.1.021

**44. Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. ¿Cuál es el tratamiento?**

A) RICE más bota removible por cuatro semanas
B) Yeso de pierna por seis semanas
C) Cirugía con reducción y osteosíntesis
D) Observación ambulatoria y control en una semana
E) Inmovilización con bota de yeso y evaluar en dos semanas

PREGUNTA 45 4.02.2.013

**45. Un paciente de 21 años sufre accidente en esquí con caída y torsión del tobillo derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se solicita radiograFa de tobillo que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Reposo con extremidad en elevación
B) Reducción cerrada e inmovilización con valva de yeso
C) Analgésicos y apoyo progresivo con mínima carga
D) Vendaje compresivo
E) Tracción e inmovilización con yeso de la extremidad

PREGUNTA 46 4.02.2.004

**46. Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa, con imposibilidad de caminar. Se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fractura de la cabeza femoral derecha
B) Fractura de zona posterior del cotilo derecho
C) Luxofractura posterior de cadera derecha
D) Fractura de pelvis inestable
E) Fractura extracapsular de cadera derecha

PREGUNTA 47 4.02.2.004

**47. Un adulto mayor de setenta años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A) Luxación posterior de cadera; TAC de cadera
B) Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis
C) Fractura de cadera; resonancia magnética de cadera
D) Fractura de fémur; radiografía de fémur en dos proyecciones
E) Coxartrosis aguda; radiografía de pelvis

PREGUNTA 48 4.02.2.004

**48. Un paciente de setenta y dos años tiene una fractura de cuello femoral desplazada. ¿Cuál es el tratamiento?**

A) DHS o tornillo dinámico de cadera
B) Prótesis de cadera
C) Tornillo canulado y observar si hace necrosis
D) Cirugía de Girdlestone
E) Inmovilización y manejo conservador por la edad

PREGUNTA 49 4.02.2.004

**49.** **Un copiloto tiene un accidente de tránsito frontal con golpe del tablero en la rodilla. Presenta imposibilidad de caminar con aducción y rotación interna de la cadera derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Fractura de cadera; osteosíntesis quirúrgica
B) Luxación posterior de cadera; reducción cerrada bajo anestesia
C) Fractura de fémur; radiografía y cirugía
D) Luxación posterior de cadera; cirugía abierta de urgencia
E) Luxación anterior de cadera; reducción cerrada

PREGUNTA 50 4.02.2.004

**50.** **En el contexto del manejo de Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 51 4.02.2.004

**51.** **Una paciente de 80 años sufrió una caída a nivel, luego de la cual no pudo levantarse, presentando mucho dolor. Al examen físico presenta acortamiento de la extremidad inferior derecha, con ligera abducción y rotación externa, sin equimosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esguince de cadera
B) Fractura de cadera
C) Luxación posterior de cadera
D) Fractura de pelvis
E) Fractura vertebral con lesión del plexo lumbar

PREGUNTA 52 4.02.2.004

**52.** **Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico es:**

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello femoral
D) Osteomielitis del extremo proximal del fémur
E) Necrosis avascular de la cabeza femoral

PREGUNTA 53 4.02.2.004

**53.** **Un hombre protagoniza un accidente de tránsito, chocando de manera frontal, contra otro automóvil. Presenta intenso dolor en la cadera derecha, que le impide caminar. En su examen tiene una rotación fija hacia interno, con aducción del muslo. El diagnóstico más probable es:**

A) Fractura de cuello femoral
B) Fractura de cotilo
C) Esguince grado 3 de cadera
D) Luxación anterior de cadera
E) Luxación posterior de cadera

PREGUNTA 54 4.02.2.004

**54.** **Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. El diagnóstico más probable es:**

A) Luxación anterior de cadera
B) Fractura intertrocantérica
C) Fractura de cuello femoral
D) Luxación posterior de cadera
E) Fractura de pelvis

## BLOQUE 4 EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

PREGUNTA 55 4.02.1.007

**55.** **Niño de 8 años con pie plano flexible asintomático. Arco plantar presente al pararse en puntillas. Sin dolor, sin limitación funcional. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a los padres: pie plano flexible fisiológico, no requiere plantillas ni tratamiento
B) Plantillas correctoras
C) Derivar a ortopedia
D) Fisioterapia intensiva
E) Cirugía correctora

PREGUNTA 56 4.02.1.007

**56.** **Paciente que comenzó a trotar, presenta dolor en el pie y callosidades; arco plantar pronunciado e hiperqueratosis anterior. ¿A qué corresponde esta alteración?**

A) Pie plano
B) Pie cavo
C) Pie equino
D) Pie varo
E) Hallux valgus

PREGUNTA 57 4.02.1.007

**57.** **Un paciente de 30 años empieza a trotar hace 2 semanas, sin embargo, refiere que deforma las zapatillas y que presenta dolor en la planta del pie y el antepié. Al examen físico se aprecia arco plantar muy marcado y callosidades en la zona anterior del pie, a nivel de la cabeza de los huesos metatarsianos. ¿Cómo se conoce esta formación del pie?**

A) Pie plano
B) Pie varo
C) Pie bot
D) Pie equino
E) Pie cavo

PREGUNTA 58 4.02.1.007

**58.** **Recién nacido con pie equino varo bilateral (CTEV) detectado al nacimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control en el próximo control de salud infantil
B) Derivar a ortopedia infantil para inicio de método Ponseti
C) Hospitalizar para cirugía inmediata
D) Observación domiciliaria: se corrige solo
E) Kinesiología ambulatoria y férulas

PREGUNTA 59 8.01.1.003

**59.** **Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. ¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?**

A) Lesión del menisco externo; radiografía de rodilla
B) Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear
C) Rotura del ligamento cruzado anterior; resonancia magnética
D) Lesión del menisco interno; radiografía de rodilla en dos proyecciones
E) Disfunción patelofemoral; solo reposo y AINEs

PREGUNTA 60 8.01.1.003

**60.** **Un futbolista sufre un mecanismo de hiperextensión de rodilla y presenta inestabilidad y cajón anterior positivo. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Rotura del ligamento cruzado posterior; tratamiento conservador
B) Rotura del ligamento cruzado anterior; cirugía artroscópica
C) Rotura del ligamento cruzado anterior; tratamiento conservador con reposo y AINEs
D) Lesión de menisco interno; maniobra de Apley para confirmar
E) Esguince de ligamento colateral lateral; inmovilizador de rodilla

PREGUNTA 61 8.01.1.003

**61.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) En Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 62 8.01.1.003

**62.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) En Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 63 1.01.1.021

**63.** **Hombre de sesenta y cinco años consulta por dolor en la rodilla derecha de seis meses de evolución que empeora al caminar y mejora con el reposo. La radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular, osteofitos marginales y esclerosis subcondral. Hasta ahora no ha recibido tratamiento. ¿Cuál es el primer escalón terapéutico indicado?**

A) Corticoides intrarticulares de rodilla derecha
B) Reemplazo articular de rodilla derecha
C) Paracetamol un gramo cada ocho horas más ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
D) Ibuprofeno más omeprazol como tratamiento de inicio
E) Tramadol oral por su mayor eficacia analgésica

PREGUNTA 64 1.01.1.021

**64.** **Mujer de cincuenta y ocho años con insuficiencia renal crónica estadio tres y úlcera duodenal activa consulta por artrosis de cadera con dolor que no cede con paracetamol. ¿Cuál es el siguiente paso correcto en el manejo?**

A) Agregar ibuprofeno más omeprazol como protección gástrica
B) Agregar celecoxib, ya que los COX-2 no producen úlcera
C) Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación
D) Corticoides orales en dosis bajas como antiinflamatorio alternativo
E) Derivar directamente a cirugía por la complejidad del caso

PREGUNTA 65 1.01.1.021

**65. En el enfrentamiento clínico sistemático de Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES) (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) En Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES), la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 66 4.02.2.011

**66. Paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera, claudicación y dolor a la palpación lateral con limitación a la rotación interna. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Coxartrosis (artrosis de cadera)
B) Síndrome de la banda iliotibial
C) Tendinopatía del glúteo medio
D) Bursitis trocantérica
E) Fractura de estrés del cuello femoral

PREGUNTA 67 4.02.2.011

**67. Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:**

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

PREGUNTA 68 4.02.2.011

**68. Futbolista de 22 años que sufre giro brusco con la rodilla semiflexionada. Presenta edema articular rápido (hemartros), signo del cajón anterior positivo y prueba de Lachman positiva. ¿Qué estructura se lesionó?**

A) Ligamento cruzado anterior (LCA)
B) Ligamento cruzado posterior (LCP)
C) Ligamento colateral medial (LCM)
D) Menisco medial
E) Ligamento patelofemoral

PREGUNTA 69 4.02.2.011

**69. Un paciente de 65 años sufre una caída a nivel, con golpe en la rodilla derecha. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se observa depresión suprarrotuliana en dicha rodilla y se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Luxación de rótula
B) Disfunción patelo-femoral
C) Rotura del ligamento cruzado anterior
D) Rotura del ligamento rotuliano
E) Rotura del ligamento del cuádriceps

PREGUNTA 70 1.08.1.001

**70. Recién nacida de dos días de vida, sexo femenino, parto en presentación podálica. En el examen físico se detecta que al flexionar y abducir la cadera se escucha un clic y la cadera luxada logra reposicionarse en el acetábulo. ¿Cuál de los siguientes describe correctamente este hallazgo?**

A) Signo de Barlow positivo: la cadera encajada se luxa al aplicar presión
B) Signo de Ortolani positivo: la cadera luxada se reduce al abducir
C) Arco de Shenton discontinuo visible en la radiografía AP de pelvis
D) Pie bot o pie zambo bilateral por artrogriposis neonatal
E) Epifisiólisis de la cabeza femoral por obesidad en el adolescente

PREGUNTA 71 1.08.1.001

**71. Niño de siete años, previamente sano, de talla baja para su edad y que practica fútbol cuatro veces por semana. Consulta por dolor en la ingle derecha y cojera de dos semanas de evolución. La radiografía AP de pelvis muestra aplanamiento y aumento de densidad de la cabeza femoral derecha en comparación con la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Sinovitis transitoria de cadera
B) Artritis séptica de cadera derecha
C) Epifisiólisis de la cabeza femoral derecha
D) Enfermedad de Perthes de cadera derecha
E) Displasia del desarrollo de cadera con luxación tardía

PREGUNTA 72 1.08.1.001

**72. En el enfrentamiento clínico sistemático de Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa) (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) En Traumatología Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 73 4.02.2.003

**73. Dolor de rodilla jugando fútbol por movimiento de torsión, al examen físico con dolor al valgo, sin bostezo:**

A) Rotura ligamento cruzado posterior
B) Ligamento cruzado anterior
C) Esguince colateral medial (pero no tenía bostezo)
D) Rotura menisco medial (tenía sentido con el mecanismo de lesión en torsión)
E) Hemograma y VHS

PREGUNTA 74 1.08.1.001

**74. Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
B) Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
C) Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
D) Fractura de calcáneo; radiografía de pie
E) Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

PREGUNTA 75 1.08.1.001

**75. Un paciente tiene dolor y edema en la pantorrilla izquierda. Refiere que desde hace varios meses tenía un bulto indoloro en la zona posterior de la rodilla que ahora desapareció. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) TVP; ecodoppler y anticoagulación urgente
B) Quiste de Baker roto; analgesia con AINEs
C) Quiste de Baker roto; cirugía de extirpación urgente
D) Hematoma de pantorrilla; frío local y AINEs
E) Esguince de rodilla; inmovilizador y AINEs

PREGUNTA 76 1.08.1.001

**76. Un paciente sufre un esguince de tobillo por inversión y presenta equimosis lateral más inestabilidad articular al examen. ¿Cuál es el grado y el tratamiento?**

A) Grado uno; solo analgesia sin inmovilización
B) Grado dos; RICE más inmovilización con órtesis removible
C) Grado tres; RICE más inmovilización con órtesis removible
D) Grado tres; cirugía de reparación ligamentaria urgente
E) Grado uno; RICE sin necesidad de radiografía

PREGUNTA 77 1.08.1.001

**77. En el contexto del manejo de Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 78 4.02.1.002

**78. Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Doble pañal
B) Correas de Pavlik
C) Yeso con fijador
D) Osteotomía periacetabular tipo Ganz
E) Reducción abierta y fijación con osteosíntesis

PREGUNTA 79 4.02.1.002

**79. Un niño de 3 meses de edad se realiza una radiografía de pelvis, que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. La indicación más adecuada es:**

A) Ejercicios de rotación y compresión
B) Bota larga bilateral de yeso, con yugo
C) Yeso pelvipedio
D) Uso de doble pañal
E) Arnés de Pavlik

PREGUNTA 80 4.02.1.002

**80. Niño de 9 años con cojera indolora progresiva de 3 semanas. Rx de cadera: aplanamiento y fragmentación de la cabeza femoral derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta?**

A) Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes: derivar a ortopedia infantil
B) Sinovitis transitoria: reposo y AINEs
C) Artritis séptica: hospitalizar y cirugía
D) Displasia del desarrollo de cadera: arnés de Pavlik
E) Osteosarcoma: biopsia urgente

PREGUNTA 81 4.02.1.009

**81. Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea herterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es:**

A) Osteocondroma
B) Tumor de células gigantes
C) Osteosarcoma
D) Displasia ósea fibrosa
E) Quiste óseo

PREGUNTA 82 4.02.1.009

**82. Un adolescente de quince años presenta dolor en el muslo derecho. La radiografía muestra una lesión en la metáfisis del fémur con disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Osteocondroma
B) Osteosarcoma
C) Sarcoma de Ewing
D) Tumor de células gigantes
E) Osteoma osteoide

PREGUNTA 83 4.02.1.009

**83. Un niño de diez años presenta dolor en la diáfisis del húmero. La radiografía muestra una lesión diafisiaria con aspecto heterogéneo, disrupción de la cortical y extensión a partes blandas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Osteosarcoma
B) Sarcoma de Ewing
C) Tumor de células gigantes
D) Osteocondroma
E) Enfermedad de Paget

PREGUNTA 84 4.02.1.009

**84. Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:**

A) Osteomielitis del fémur distal
B) Osteosarcoma osteogénico
C) Fractura del fémur distal, con callo óseo
D) Osteocondroma
E) Hematoma calcificado

PREGUNTA 85 1.10.1.001

**85. Hombre de cuarenta y dos años consulta por lumbago de tres semanas de evolución. Refiere que el dolor aumenta al moverse y mejora significativamente cuando está acostado en reposo. No tiene fiebre, ni baja de peso, ni irradiación a extremidades, ni debilidad muscular. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Solicitar resonancia magnética lumbar para estudio etiológico
B) Reposo absoluto en cama por dos semanas hasta la remisión del dolor
C) Reposo relativo, AINE y derivación a quinesioterapia una vez aliviado el dolor
D) Corticoides orales por el componente inflamatorio del cuadro
E) Derivación urgente a neurocirugía por riesgo de compresión medular

PREGUNTA 86 1.10.1.001

**86. Mujer de treinta y cinco años deportista, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho que lleva dos meses de evolución y que aumenta al extender la muñeca contra resistencia. No hay eritema ni aumento de volumen articular. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial correcto?**

A) Bursitis del olécranon: AINE más calor local
B) Epitrocleitis o codo del golfista: reposo, AINE y epicondilera
C) Artritis séptica de codo: punción articular urgente y antibióticos
D) Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y quinesioterapia
E) Tendinitis del manguito rotador: ecografía de hombro y corticoides

PREGUNTA 87 1.10.1.001

**87. Mujer de cuarenta y ocho años consulta por dolor generalizado en múltiples grupos musculares, fatiga crónica y trastornos del sueño de ocho meses de evolución. Al examen tiene dolor a la compresión en puntos cervicales, trapecios, epicóndilos y cara medial de las rodillas. La VHS y la PCR están dentro de rangos normales. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?**

A) Polimialgia reumática: corticoides orales en dosis bajas
B) Fibromialgia: ejercicio físico más moduladores del dolor como pregabalina
C) Artritis reumatoide: metotrexato como fármaco modificador de la enfermedad
D) Polimiositis: biopsia muscular y corticoides sistémicos
E) Lumbago crónico con irradiación generalizada: resonancia magnética lumbar

PREGUNTA 88 1.10.1.001

**88. En el contexto del manejo de Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica), ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto al diagnóstico y tratamiento representa la conducta correcta de acuerdo a las guías de práctica clínica?**

A) Se debe realizar inmovilización adecuada, evaluación neurovascular distal y derivación prioritaria.
B) Está indicada la movilización precoz forzada sin inmovilización previa.
C) Se debe diferir el estudio radiológico hasta que ceda completamente el edema de partes blandas.
D) El tratamiento farmacológico exclusivo con reposo absoluto sustituye a la reducción en fracturas desplazadas.
E) La infiltración intraarticular con corticoides es la primera línea terapéutica en casos agudos traumáticos.

PREGUNTA 89 4.02.1.005

**89.** **Hombre de 45 años con lumbalgia mecánica de 5 días de evolución, sin irradiación, sin signos de alarma. EF: dolor a la palpación paravertebral lumbar, sin déficit neurológico. ¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Analgesia (AINEs o paracetamol) + kinesioterapia activa; no reposo en cama
B) Reposo absoluto por 7 días
C) Cirugía de columna
D) Infiltración epidural de corticoides
E) Resonancia magnética urgente

PREGUNTA 90 4.02.1.005

**90.** **Un paciente de 40 años, oficinista, estuvo moviendo muebles durante 2 días, evolucionando luego con intenso dolor lumbar, que le impide realizar sus actividades. Al examen físico se aprecia muy adolorido, con dificultades para subirse a la camilla y para caminar, tiene IMC de 28 y se observa una contractura muscular a nivel lumbar, con dolor ante todos los movimientos de la columna lumbar, sin signos de irritación nerviosa. Además de administrar analgésicos, la indicación más adecuada es:**

A) Resonancia magnética nuclear
B) Radiografía de columna lumbosacra
C) Kinesioterapia motora por 10 días
D) Reposo en cama por 5 días
E) Reposo laboral por 3 días

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: E

4.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Escoliosis y deformidades vertebrales**

Tiene una clásica fractura vertebral por aplastamiento del cuerpo vertebral, causada por osteoporosis, que también fue la causa de su fractura de muñeca.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A

4.02.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Heridas de la mano no complicadas**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas de la mano no complicadas" como urgencia clínica (4.02.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo GES

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

La opción correcta es la B. Opción A: La crepitación ósea con deformidad y desviacón de ejes orienta claramente a fractura, no a una contusión. El estudio inicial es radiografía en dos proyecciones. Opción B: Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. El diagnóstico se confirma con radiografías en más de una proyección: anteroposterior más lateral. Opción C: La crepitación ósea es característica de fractura. El TAC no es el examen inicial; la radiografía en dos proyecciones es el estudio de primera línea. Opción D: Las fracturas de huesos largos requieren siempre más de una proyección. No es suficiente solo la anteroposterior; se necesita también la proyección lateral. Opción E: La crepitación y la deformidad indican fractura, no solo contusión. Toda sospecha de fractura requiere radiografías para confirmar el diagnóstico.

### PREGUNTA 4 Respuesta: B

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo GES

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

La opción correcta es la B. Opción A: Una fractura conminuta e irreductible no puede manejarse con yeso solamente. Tiene indicación quirúrgica por el riesgo de no-unión y mala unión. Opción B: Una fractura muy desplazada e irreductible más conminución son indicaciones claras de cirugía. El tratamiento es reducción más osteosíntesis con placa, tornillos o agujas de Kirschner. Opción C: La fractura conminuta irreductible tiene indicación de cirugía. La tracción prolongada no es el manejo adecuado cuando hay indicación quirúrgica clara. Opción D: Las fracturas conminutas no consolidan solas. Tienen alto riesgo de pseudoartrosis y consolidación viciosa, por lo que requieren cirugía. Opción E: Una fractura conminuta irreductible no puede manejarse solo con órtesis funcional. La indicación quirúrgica es clara en este caso.

### PREGUNTA 5 Respuesta: B

4.02.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

Por el corto tiempo de evolución y el dolor es síndrome compartimental. Además es clásico de las Fx de antebrazo. Falta información

**PREGUNTA 6** **Respuesta: B**

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

4.02.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una clásica epifisiolisis de la cabeza femoral (adolescente con claudicación de la marcha y dolor en la cadera. Se asocia a sobrepeso y obesidad). Además, se ve el signo del “helado caído”.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

4.02.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una fractura de muñeca clásica.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: E**

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

4.02.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

, ¿B?. El cabestrillo y el vendaje en 8 son los más usados en las fracturas del tercio medio de clavícula. Sin embargo, también se pueden usar otros tipos de inmovilización, según la valoración por el especialista. El vendaje en 8 se asocia a mayores molestias, por compresión cutánea y del complejo neurovascular axilar, así que el cabestrillo suele ser lo más recomendado. De todos, modos, es una pregunta de especialista.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

**Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización**

4.02.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Fracturas expuestas" como urgencia clínica (4.02.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

**Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente**

1.12.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. Opción A: La fractura expuesta grado 1 requiere cobertura para gram positivos especialmente estafilococo aureus. La cefazolina es la cefalosporina de primera línea para esto. Opción B: La combinación con amikacina es para el grado 2 cuando se necesita agregar cobertura para gram negativos. El grado 1 solo requiere cefazolina. Opción C: Esta triple combinación es para el grado 3. El grado 1 solo requiere cefazolina para gram positivos. Opción D: El metronidazol cubre anaerobios y se usa en grado 3. El grado 1 requiere cefazolina para gram positivos. Opción E: El tratamiento endovenoso es el indicado en la fractura expuesta. La vía oral no es adecuada en este contexto.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

**Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente**

1.12.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El grado 2 es herida entre uno y diez centímetros. Una herida de quince centímetros muy contaminada corresponde al grado 3. Opción B: Herida mayor de diez centímetros muy contaminada es grado 3. Requiere triple cobertura: cefazolina gram positivos, amikacina gram negativos y clindamicina anaerobios. Opción C: El grado 1 es herida menor de un centímetro con mínima contaminación. Esta fractura es claramente grado 3. Opción D: El metronidazol solo no es suficiente. El grado 3 requiere triple cobertura para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Opción E: El grado 2 requiere cefazolina más amikacina. Además esta fractura corresponde al grado 3 por la herida grande y muy contaminada.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

**Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente**

1.12.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: No se debe suturar la herida porque necesita aseo quirúrgico en pabellón. El yeso circular puede generar síndrome compartimental. Opción B: La herida se cubre con apósitos estériles sin suturar. La valva de yeso debe ser larga para mejor inmovilización y abierta para prevenir síndrome compartimental. Opción C: La herida debe cubrirse con apósitos estériles para evitar mayor contaminación. La inmovilización es obligatoria para el traslado. Opción D: No se debe suturar la herida. La valva debe ser larga para mejor inmovilización, no corta. Opción E: El yeso circular puede causar síndrome compartimental. Se debe usar valva de yeso larga y abierta.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: A**

**Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente**

1.12.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. En Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

**Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: La embolia grasa aparece en las primeras horas con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias, no días después con disnea súbita. El dímero D no es el examen de elección. Opción B: El TEP aparece días después de una fractura con disnea o dolor torácico súbito. El angiotac de tórax es el examen de elección. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. Opción C: Aunque el diagnóstico de TEP es correcto, el dímero D no es útil en este contexto porque la fractura misma lo eleva, generando un falso positivo que no aporta al diagnóstico. Opción D: El síndrome compartimental aparece en horas con dolor intenso en la extremidad que aumenta con movilidad distal, no con disnea súbita días después. Opción E: Una neumonía no se presenta súbitamente días después de una fractura. El cuadro súbito de disnea post fractura orienta a TEP.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: C**

**Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la C. Opción A: La distrofia simpático refleja aparece semanas a meses después, no en horas. El dolor es neuropático urente, no somático inmediato. La conducta también es diferente. Opción B: La TVP aparece días después y se presenta con dolor muscular al palpar, edema y signo de Homans, no con dolor que aumente al mover los dedos en horas post cirugía. Opción C: El síndrome compartimental aparece en horas con dolor somático intenso que aumenta con la movilidad distal. La fasciotomía amplia es el tratamiento de urgencia para evitar necrosis de la extremidad. Opción D: Retirar el yeso y elevar la extremidad solo está indicado al inicio con dolor leve sin signos de isquemia. Con dolor muy intenso a las cuatro horas se requiere fasciotomía urgente. Opción E: El dolor que aumenta con la movilidad distal en horas post fractura no es dolor postoperatorio normal, orienta a síndrome compartimental que requiere manejo urgente.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

**Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El TEP aparece días después con disnea súbita, no en horas con la tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias. La tríada petequial es característica de embolia grasa. Opción B: La embolia grasa aparece en horas con tríada de distrés respiratorio, compromiso de conciencia y rash petequial. Se asocia a fracturas de huesos largos como el fémur. El tratamiento es solo soporte, no hay fármacos con eficacia demostrada. Opción C: El diagnóstico de embolia grasa es correcto, pero el tratamiento no es la anticoagulación. El único tratamiento disponible es el soporte, no hay fármacos con eficacia demostrada. Opción D: El síndrome compartimental se presenta con dolor intenso en la extremidad que aumenta con la movilidad distal, no con distrés respiratorio, compromiso de conciencia y petequias. Opción E: La distrofia simpático refleja aparece semanas a meses después con dolor neuropático y cambios tróficos, no en horas con distrés respiratorio y petequias.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

**Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente**

1.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. En Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: C**

**Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente**

4.02.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta muy rara, ya que parece un síndrome de manguito rotador. Sin embargo, el ascenso de la cabeza humeral orienta a la rotura del tendón supraespinoso. La tendinitis cálcica tendría calcificación del tendón del bíceps, lo que se vería. La capsulitis adhesiva limitaría totalmente los movimientos.

---

## BLOQUE 2 GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D** **Infecciones osteoarticulares** 4.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la PNA se hizo un absceso perirrenal, que se extendio al disco IV e hizo una espondilodiscitis. Es pregunta del MIR. La fiebre más lumbago mecánico es espondilodiscitis. La fiebre más lumbago inflamatorio, en cambio, es espondilitis anquilosante.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: C** **Politraumatizado** 4.02.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La sospecha clínica es un neumotórax a tensión, cuyo manejo es prioritario en el ABC. Se debe descomprimir de inmediato, mediante punción o toracostomía de urgencia. Si se punciona, se suele hacer en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal, o en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: B**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El nervio mediano se lesiona en la fractura supracondílea de húmero, no en la diáfisis. Produce déficit de flexión de los primeros tres dedos, no de extensión. Opción B: El nervio radial está adherido a la diáfisis humeral. Su lesión produce imposibilidad de extender dedos y muñeca más hipoestesia de la cara posterior de la extremidad superior. Opción C: El nervio cubital se lesiona en fracturas de codo y produce déficit de flexión del cuarto y quinto dedo, no de extensión. Se asocia a fractura de codo, no de diáfisis humeral. Opción D: El nervio axilar se lesiona en luxación de hombro y produce incapacidad para abducir el brazo, no para extender la muñeca. Opción E: El nervio ciático está en la extremidad inferior y se lesiona en luxación posterior de cadera. No tiene relación con la fractura de húmero.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: C**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la C. Opción A: El nervio radial se lesiona en la fractura de diáfisis humeral y produce déficit de extensión de dedos y muñeca, no de abducción del hombro. Opción B: El nervio mediano se lesiona en la fractura supracondílea de húmero y produce déficit de flexión de los primeros tres dedos, no de abducción del hombro. Opción C: El nervio axilar inerva el deltoides y la piel sobre él. Se lesiona clásicamente en la luxación anterior de hombro, produciendo incapacidad de abducción y hipoestesia sobre el deltoides. Opción D: El nervio cubital se lesiona en fracturas de codo y produce déficit de flexión del cuarto y quinto dedo más hipoestesia del quinto dedo. Opción E: El nervio ciático está en la extremidad inferior y se lesiona en luxación posterior de cadera, no tiene relación con la luxación de hombro.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: D**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

4.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Parece una bursitis trocantérica clásica.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

4.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

por llevar dos años orienta a artrosis (coxartrosis = artrosis de cadera). Alguien anotó 2 semanas en FB: sería la necrosis avascular.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: E**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

4.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es una artrosis de cadera, tanto por la clínica, como por la radiografía.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: D**

**Complicaciones Graves de Fracturas: Embolia Grasa, Pseudoartrosis & Osteomielitis Postraumática**

4.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

En mi opinión tiene indicación de reemplazo articular. Pero la decisión exacta co- rresponde al especialista, según cada caso.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

**Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: Las radiografías mínimas en un politraumatizado son lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. La radiografía de abdomen no es parte del estudio mínimo inicial. Opción B: Estas tres proyecciones son el estudio mínimo en un politraumatizado: lateral de cuello para descartar fractura cervical, AP de tórax para neumotórax o hemotórax, y AP de pelvis para fractura de pelvis. Opción C: El TAC de cerebro no es parte de las tres radiografías mínimas iniciales. Las mínimas son lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. Opción D: Un politraumatizado requiere siempre las tres proyecciones mínimas independientemente de su estabilidad: lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis. Opción E: No se piden radiografías de todos los huesos largos inicialmente. El estudio mínimo son solo tres proyecciones específicas: lateral de cuello, AP de tórax y AP de pelvis.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: C**

**Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la C. Opción A: La transfusión puede ser parte del manejo pero no controla la fuente de sangrado. Lo urgente es estabilizar la pelvis para reducir la capacitancia y frenar la hemorragia venosa pélvica. Opción B: La cirugía no es lo más urgente ni lo inicial. La estabilización externa de la pelvis es la primera medida para controlar la hemorragia venosa pélvica. Opción C: La pelvis abierta tiene mayor capacitancia para acumular sangre. Estabilizarla y comprimirla reduce ese espacio y frena la hemorragia venosa. Se puede usar sábana enrollada, amaca pélvica o tutores externos. Opción D: La sonda Foley está contraindicada en fractura de pelvis sin descartar sección uretral. La conducta urgente es estabilizar la pelvis para controlar la hemorragia. Opción E: La hemorragia en fractura de pelvis es principalmente venosa, no arterial. La medida urgente es la estabilización externa de la pelvis, no la embolización arterial.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

**Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: La sonda Foley está absolutamente contraindicada si se sospecha sección uretral porque puede crear una falsa vía y generar más daño. Se debe instalar cistostomía. Opción B: La sonda Foley está contraindicada en sección uretral. El manejo correcto es cistostomía para drenar la vejiga, uretrocistografía para el diagnóstico y cirugía para reparar la uretra. Opción C: Si se sospecha sección uretral con globo vesical, primero se instala la cistostomía para drenar la vejiga y luego se hace la uretrocistografía diagnóstica. No se instala sonda Foley. Opción D: La retención urinaria con globo vesical en un politraumatizado no puede quedar sin manejo. Hay que drenar la vejiga con cistostomía y estudiar la uretra con uretrocistografía. Opción E: Aunque el TAC puede ayudar a ver la fractura, la urgencia en este momento es drenar la vejiga. La sonda Foley está contraindicada y la cistostomía es la conducta inmediata.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

**Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz**

1.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: D**

**Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz**

4.02.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una probable fractura de pelvis, pero por tener compromiso hemodinámico, lo más urgente es poner una vía venosa, administrar fluidos y estabilizar la pelvis (por ejemplo con una sábana pélvica).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

**Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular**

4.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal y sin dolor, con partes blandas interpuestas en la radiografía. Este paciente tiene dolor leve y callo en formación, que corresponde a retraso de consolidación. Opción B: El retraso de consolidación se presenta con dolor persistente más allá del tiempo normal y radiografía con callo óseo en maduración. El tratamiento es mejorar la inmovilización, que era la causa. Opción C: La consolidación viciosa tiene consolidación ya completada pero desviada. Este paciente aún no ha consolidado, lo que corresponde a retraso de consolidación. Opción D: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal en el foco y la radiografía muestra partes blandas interpuestas, no callo en formación. Este caso tiene callo en maduración que es retraso de consolidación. Opción E: La osteomielitis tiene fiebre, eritema y secreción. El callo óseo en formación con dolor leve después de una fractura en yeso corresponde a retraso de consolidación.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

**Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular**

4.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El retraso de consolidación tiene dolor persistente y callo en maduración. Este paciente tiene movilidad anormal y sin dolor con la imagen radiográfica de partes blandas interpuestas. Opción B: La pseudoartrosis hipertrófica tiene movilidad anormal sin dolor, extremos óseos en pata de elefante y partes blandas interpuestas, causada por mala inmovilización. El tratamiento es siempre quirúrgico. Opción C: La consolidación viciosa tiene el hueso ya consolidado pero desviado, sin movilidad anormal en el foco. Este caso tiene movilidad anormal que indica que no consolidó. Opción D: La pseudoartrosis atrófica tiene extremos óseos atróficos por mala irrigación. Este caso tiene extremos hipertróficos en pata de elefante que corresponde a la variante hipertrófica por mala inmovilización. Opción E: Una fractura patológica tiene causa subyacente como tumor u osteoporosis. La imagen de pseudoartrosis hipertrófica con extremos en pata de elefante es característica de mala inmovilización previa.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: C**

**Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular**

4.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la C. Opción A: El retraso de consolidación tiene dolor persistente y callo en maduración, no consolidación completa con desviación. El hueso ya consolidó en este caso. Opción B: La pseudoartrosis tiene movilidad anormal sin dolor y partes blandas interpuestas. Este caso tiene consolidación completa, aunque desviada, que corresponde a consolidación viciosa. Opción C: La consolidación viciosa tiene el hueso consolidado de manera desviada sin dolor, por mala reducción o mala inmovilización. El tratamiento es refractura quirúrgica con nueva reducción e inmovilización adecuada. Opción D: Una fractura patológica se da en contexto de tumor u osteoporosis. Una fractura que consolidó desviada en un adulto joven corresponde a consolidación viciosa por mala reducción o inmovilización. Opción E: Una consolidación con desviación de los ejes no es normal. La mala unión o consolidación viciosa produce problemas funcionales y requiere tratamiento quirúrgico.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: A**

**Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular**

4.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. En Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: C**

**Trauma Raquimedular: Clasificación ASIA, Inmovilización Cervical, Shock Neurogénico vs Medular**

4.02.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Fractura Vertebral: Aunque inicialmente parece un lumbago mecánico, la edad, la curvatura torácica y el dolor a la palpación vertebral sugieren una fractura vertebral como diagnóstico más probable.

---

## BLOQUE 3 EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: E** **Lumbociática radicular** 4.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto la compresión del cono medular como de la cauda equina se presentan con anestesia en silla de montar y disfunción sexual. De las opciones, la más razonable es el síndrome de cauda equina, ya que el síndrome de compresión medular clásico Gene compromiso motor y sensitivo, sin tanta afectación pudenda, con excepción del cono medular, que ya se explicó.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A** **Lumbociática radicular** 4.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Lumbociática radicular.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides**

1.14.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Opción A: La radiografía normal no descarta la fractura de escafoides. El dolor en la tabaquera anatómica es fractura de escafoides hasta descartarse con TAC. Opción B: El TAC es el examen de elección para la fractura de escafoides porque la radiografía puede ser normal incluso con fractura. Si el TAC está normal, ahí sí se descarta. Opción C: La ecografía no es el examen de elección para fractura de escafoides. El TAC es el examen de elección ante dolor en la tabaquera anatómica con radiografía normal. Opción D: Aunque la RMN puede detectar fracturas de escafoides, el TAC es el examen de elección según la clase. Si no hay TAC disponible, se inmoviliza la mano. Opción E: La inmovilización es correcta si no hay TAC disponible, pero siempre se debe solicitar TAC para confirmar o descartar la fractura. No se puede quedar sin diagnóstico definitivo.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

**Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides**

1.14.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. Opción A: La fractura de Galeazzi es fractura de diáfisis del radio más luxación del cúbito distal. La fractura de la diáfisis cubital más luxación de cúpula radial es de Monteggia. Opción B: La fractura de Colles es una fractura de muñeca con deformidad en dorso de tenedor. No involucra la diáfisis cubital ni la cúpula radial. Opción C: La fractura de Monteggia es la fractura de la diáfisis cubital más la luxación de la cúpula radial. La de Galeazzi es al revés: fractura de radio más luxación del cúbito distal. Opción D: La fractura supracondílea de húmero afecta el extremo distal del húmero con riesgo de lesión de arteria braqueal y nervio mediano, no involucra el antebrazo. Opción E: La fractura subcapital de húmero afecta el extremo proximal del húmero y es característica del adulto mayor con osteoporosis, no es una lesión del antebrazo.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

**Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides**

4.02.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Fractura de húmero + caída de muñeca (wrist drop) = lesión del nervio radial en el canal de torsión (surco espiral). Inerva extensores de muñeca y dedos (ECC, ECD, ELP).

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: E**

**Lesiones de Hombro, Clavícula y Miembro Superior: Luxación Glenohumeral, Fractura de Colles & Escafoides**

4.02.2.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La luxación anterior de hombro se reduce ortopédicamente, de inmediato. Si recurre, se trata con cirugía.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

**Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles**

1.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Opción A: Toda lesión de tobillo requiere radiografía para descartar fractura antes del alta. La dificultad para apoyar además orienta a fractura. Opción B: Ante toda lesión de tobillo se pide radiografía siempre para descartar fractura. La imposibilidad de apoyar es un signo que orienta a fractura. El diagnóstico de esguince se hace solo cuando la radiografía es normal. Opción C: El diagnóstico de esguince requiere que la radiografía sea normal. No se puede diagnosticar esguince sin descartar primero una fractura con radiografía. Opción D: El TAC no es el examen inicial en lesiones de tobillo. La radiografía simple es suficiente para descartar fractura. Opción E: La RMN puede evaluar los ligamentos pero no es el examen inicial. Primero se descarta fractura con radiografía simple.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

**Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles**

1.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. Opción A: El RICE con bota es el tratamiento del esguince de tobillo, no de la fractura de tobillo. Las fracturas de tobillo se tratan quirúrgicamente. Opción B: El yeso es tratamiento ortopédico pero por regla general las fracturas de tobillo requieren tratamiento quirúrgico. Opción C: Las fracturas de fémur, pierna y tobillo se tratan quirúrgicamente por regla general. La cirugía permite la reducción y fijación adecuada y permite al paciente apoyar antes. Opción D: Una fractura de tobillo confirmada no se puede observar sin tratamiento. El tratamiento es quirúrgico por regla general. Opción E: La fractura de tobillo requiere cirugía. La inmovilización solo puede ser parte del manejo perioperatorio, no el tratamiento definitivo.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

**Lesiones de Tobillo y Pie: Fracturas Maleolares, Reglas de Ottawa & Rotura del Tendón de Aquiles**

4.02.2.013 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Tiene una luxofractura de tobillo, cuyo manejo es quirúrgico. Sin embargo, el manejo inicial consiste en analgesia, reducción cerrada (bajo anestesia o sedación) e inmovilización transitoria, con valva de yeso abierta, para evitar un síndrome compartimental. Este mismo manejo aplica a otras fracturas desplazadas, mientras se espera la cirugía. Fuente imagen: Radiopaedia.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: C**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Está en posición púdica, clásica de la luxación posterior de cadera; y la radiografía muestra la luxación posterior derecha. No queda claro el rasgo de fractura.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: La luxación posterior produce posición púdica con aducción y rotación interna, no la posición impúdica con abducción y rotación externa. El estudio inicial es radiografía, no TAC. Opción B: La posición impúdica con abducción, rotación externa y acortamiento es el signo clásico de fractura de cadera. El diagnóstico se hace con radiografía AP y axial de cadera más AP de pelvis. Opción C: La fractura de cadera se diagnostica con radiografía, no con resonancia magnética. La resonancia es para lesiones de partes blandas como meniscos y ligamentos. Opción D: La posición impúdica con abducción y rotación externa localiza la lesión en la cadera, no en la diáfisis femoral. La radiografía de cadera es el estudio inicial. Opción E: La coxartrosis no produce la posición impúdica ni la incapacidad súbita de caminar tras una caída. El antecedente de caída más la posición impúdica orienta claramente a fractura de cadera.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: B**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El DHS se usa en las fracturas intertrocantéricas. En la fractura de cuello femoral desplazada en mayor de sesenta y cinco años, la indicación es prótesis de cadera. Opción B: Fractura de cuello femoral más desplazada más mayor de sesenta y cinco años son las tres condiciones para indicar prótesis. El riesgo de necrosis avascular es muy alto y se prefiere prótesis desde el inicio. Opción C: El tornillo canulado se usa en fractura de cuello en menores de sesenta y cinco años o no desplazada. En mayor de sesenta y cinco años con fractura desplazada, el riesgo de necrosis es tan alto que se prefiere prótesis de entrada. Opción D: La cirugía de Girdlestone retira la cabeza femoral y se indica en pacientes postrados, no en pacientes que caminan. Un paciente de setenta y dos años que camina merece prótesis. Opción E: La fractura de cadera siempre requiere tratamiento quirúrgico independientemente de la edad. El manejo conservador en una fractura de cadera tiene mortalidad muy alta por complicaciones del reposo.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: La fractura de cadera tiene posición impúdica con abducción y rotación externa. Este paciente tiene aducción y rotación interna que corresponde a la posición púdica de la luxación posterior. Opción B: El mecanismo de golpe del tablero en la rodilla del copiloto empuja la cadera hacia atrás produciendo luxación posterior. La posición púdica con aducción y rotación interna lo confirma. El tratamiento es reducción cerrada bajo anestesia. Opción C: La fractura de fémur produce dolor en el muslo con crepitación. El mecanismo de tablero en rodilla con la posición púdica es característico de luxación posterior de cadera. Opción D: El diagnóstico de luxación posterior de cadera es correcto, pero el tratamiento es reducción cerrada bajo anestesia, no cirugía abierta. Opción E: La luxación anterior produce posición impúdica con abducción y rotación externa. El mecanismo de tablero en rodilla del copiloto produce luxación posterior con posición púdica.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la A. En Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una fractura de cadera clásica, con la posición impúdica.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por clínica y por radiografía, tiene una epifisiolisis de la cabeza femoral izquierda.

**PREGUNTA 53** **Respuesta: E**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una luxación posterior clásica, con la posición impúdica.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: D**

**Fracturas de Cadera en el Adulto Mayor: Cuello Femoral vs Transtrocantérica & Protocolo Quirúrgico GES < 48 h**

4.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La posición púdica es característica de la luxación posterior. La fractura, en cambio tiene posición impúdica (abducción, rotación externa y acortamiento).

## BLOQUE 4 EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Pie plano** 4.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pie plano flexible en niño (<10 años) con arco que reaparece al puntillas = fisiológico. No hay evidencia de que las plantillas modifiquen el desarrollo del arco. Solo se trata si es doloroso o rígido.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B** **Pie plano** 4.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pie cavo

**PREGUNTA 57** **Respuesta: E** **Pie plano** 4.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Pie plano.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B** **Pie plano** 4.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pie equino varo congénito: derivación URGENTE a ortopedia pediátrica para inicio del método de Ponseti (yesos seriados + tenotomía percutánea del Aquiles si necesario). Debe comenzarse en las primeras semanas de vida para mejores resultados. Es corregible con tratamiento precoz.

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

**Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda**

8.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo | GES

La opción correcta es la B. Opción A: Si duele a la rotación externa es el menisco interno el afectado. Además la radiografía no diagnostica lesiones meniscales porque son tejido blando. Opción B: Con la maniobra de Apley el talón apunta al menisco afectado: si duele a la rotación externa está lesionado el menisco interno. El diagnóstico se confirma con resonancia magnética nuclear. Opción C: La rotura del ligamento cruzado anterior produce inestabilidad y cajón anterior, no bloqueo articular. El bloqueo articular es característico de lesión meniscal. Opción D: El diagnóstico de menisco interno es correcto según la maniobra de Apley, pero la radiografía no ve los meniscos. El examen de elección es la resonancia magnética. Opción E: La disfunción patelofemoral produce dolor anterior de rodilla con actividad sin bloqueo articular. El bloqueo articular orienta a lesión meniscal.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda**

8.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo | GES

La opción correcta es la B. Opción A: El cajón anterior es signo de rotura del ligamento cruzado anterior, no del posterior. El cajón posterior indica lesión del cruzado posterior. Opción B: El cajón anterior es el signo de rotura del ligamento cruzado anterior. La rotura del cruzado anterior siempre se opera artroscópicamente porque de lo contrario queda con inestabilidad permanente. Opción C: La rotura del ligamento cruzado anterior no se trata conservadoramente porque queda con demasiada inestabilidad. Siempre se opera artroscópicamente. Opción D: La lesión de menisco produce bloqueo articular, no inestabilidad con cajón anterior. El cajón anterior es específico de rotura del ligamento cruzado anterior. Opción E: El esguince colateral lateral produce signo de bostezo hacia lateral por varo forzado, no cajón anterior. El cajón anterior es específico del cruzado anterior.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda**

8.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda, la conducta médica prioritaria es: En Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

**Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda**

8.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial y Completo · Seg: Completo | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla: LCA (Lachman), Meniscos (McMurray) & Hemartrosis Aguda, la conducta médica prioritaria es: En Lesiones Ligamentosas y Meniscales de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: C**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

1.01.1.021 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La opción correcta es la C. Opción A: Los corticoides intrarticulares corresponden a una etapa avanzada del tratamiento escalonado de la artrosis, cuando han fallado el paracetamol, los AINE y los opiáceos. No son el primer escalón. Opción B: La cirugía con prótesis articular es la última línea de tratamiento en la artrosis, reservada para cuando todos los tratamientos médicos han fracasado. No es el manejo inicial. Opción C: El primer escalón del tratamiento de la artrosis es el paracetamol en dosis altas, habitualmente un gramo cada ocho horas, combinado con ejercicio de fortalecimiento muscular, especialmente del cuádriceps para la artrosis de rodilla. Está demostrado que disminuye el dolor. Opción D: Los AINE como el ibuprofeno corresponden al segundo escalón terapéutico, cuando el paracetamol más el ejercicio no han logrado controlar el dolor. No son el tratamiento inicial. Opción E: El tramadol, un opioide débil, es el tercer escalón en el tratamiento de la artrosis, indicado solo cuando el paracetamol y los AINE han fallado. Comenzar con opioides sería saltarse dos escalones del tratamiento.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: C**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

1.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. Opción A: Los AINE están contraindicados en esta paciente por la úlcera duodenal activa y la insuficiencia renal crónica. Aunque se agregue omeprazol, el riesgo renal persiste y es una contraindicación formal. Opción B: Si bien los inhibidores COX-2 tienen menor riesgo gastrointestinal, siguen estando contraindicados en insuficiencia renal crónica porque pueden deteriorar la función renal. En esta paciente se deben evitar todos los AINE. Opción C: Cuando los AINE están contraindicados, ya sea por úlcera péptica activa o insuficiencia renal crónica, el protocolo indica saltar ese escalón y pasar directamente del paracetamol al tramadol. Esta es una pregunta clásica del EUNACOM sobre el tratamiento escalonado de la artrosis. Opción D: Los corticoides orales no forman parte del tratamiento escalonado de la artrosis. Los corticoides que pueden indicarse son los intrarticulares, y solo cuando han fallado el paracetamol, AINE y opiáceos. Opción E: La cirugía es la última línea del tratamiento de la artrosis. Aún no se han agotado las opciones médicas disponibles para esta paciente, como los opiáceos y los corticoides intrarticulares.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: A**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

1.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES), la conducta médica prioritaria es: En Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES), la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: D**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

4.02.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Bursitis trocantérica

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: D**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

4.02.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Lesiones de partes blandas (contusiones,.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: A**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

4.02.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cajón anterior (+) + Lachman (+) + hemartros post trauma en valgus/rotación = ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA). Es la lesión ligamentaria más frecuente en deportistas jóvenes.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: E**

**Lesiones de Partes Blandas, Artrosis & Patología Degenerativa Articular (Coxartrosis / Gonartrosis GES)**

4.02.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Solo por la anatomía es posible adivinar la respuesta. El ligamento del cuádriceps está sobre la rótula. El tendón rotuliano está debajo de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

**Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Opción A: El signo de Barlow es el opuesto: la cadera está encajada y se puede luxar con la maniobra. En este caso la cadera estaba luxada y se logró reducir, lo que corresponde al signo de Ortolani. Opción B: El signo de Ortolani indica que la cadera viene basalmente luxada y al realizar la maniobra de abducción y flexión, el examinador logra reposicionarla o reducirla al acetábulo. Es el hallazgo clásico de displasia del desarrollo de cadera en el recién nacido. Opción C: El arco de Shenton es un hallazgo radiográfico, no un signo clínico de exploración física. El enunciado describe una maniobra clínica en el recién nacido, no un hallazgo imagenológico. Opción D: El pie zambo es una deformidad del pie, no de la cadera. El hallazgo descrito en el enunciado es específico de la displasia del desarrollo de cadera, con reducción de la articulación luxada. Opción E: La epifisiólisis ocurre en adolescentes de doce a quince años, frecuentemente obesos, no en recién nacidos. El enunciado describe claramente una patología neonatal.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: D**

**Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la D. Opción A: La sinovitis transitoria afecta a niños de dos a cuatro años, presenta radiografía normal y suele asociarse a infección respiratoria viral previa. La radiografía alterada y la edad descartan este diagnóstico. Opción B: La artritis séptica cursa con fiebre, compromiso sistémico y líquido articular inflamatorio con bacterias. El enunciado no describe estos hallazgos sistémicos, y la radiografía sugiere otra entidad. Opción C: La epifisiólisis ocurre en adolescentes de doce a quince años, frecuentemente obesos. La radiografía muestra separación de la epifisis, no aplanamiento ni aumento de densidad. Este paciente tiene siete años y talla baja. Opción D: La enfermedad de Perthes es una necrosis avascular de la cabeza femoral en niños de cinco a diez años. Se asocia a talla baja y actividad física intensa. La radiografía muestra aplanamiento y aumento de densidad de la cabeza femoral, hallazgos clásicos de esta entidad. Opción E: La displasia del desarrollo de cadera se diagnostica en recién nacidos y lactantes. A los siete años con radiografía que muestra aplanamiento y esclerosis de la cabeza femoral, el diagnóstico es la enfermedad de Perthes.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Traumatología Infantil: Fracturas en Tallo Verde, Epifisiolisis (Salter-Harris) & Codo de Niñera (Pronación Dolorosa), la conducta médica prioritaria es: En Traumatología Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

## BLOQUE 5 ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C** **Esguince grado1** 4.02.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 57). Evalúa el manejo clínico de Esguince grado1 según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción correcta es la B. Opción A: El esguince de tobillo se produce por inversión o eversión y afecta los ligamentos laterales, no produce el síntoma del piedrazo ni altera la maniobra de Thompson. Opción B: El síntoma del piedrazo con dolor súbito muy intenso en el talón al correr más la maniobra de Thompson alterada son el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. Requiere cirugía urgente antes de que los gastrocnemios se retraigan. Opción C: La rotura del tendón de Aquiles requiere cirugía urgente, no solo inmovilización. Si se demora en operar los gastrocnemios se retraen y es difícil unir los extremos. Opción D: La fractura de calcáneo tiene mecanismo de caída de altura aterrizando en el pie, no el síntoma del piedrazo al correr. La maniobra de Thompson alterada orienta a rotura del tendón de Aquiles. Opción E: El desgarro muscular de gemelos no produce la maniobra de Thompson alterada ni el síntoma del piedrazo en el talón. La maniobra de Thompson alterada es específica de rotura del tendón de Aquiles.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

1.08.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La opción correcta es la B. Opción A: La TVP tiene antecedente de trombofilia, inmovilidad o fractura. El antecedente de bulto previo en la fosa poplítea que desapareció orienta a quiste de Baker roto, no TVP. Opción B: El antecedente del bulto en la fosa poplítea que desapareció más el dolor y edema en la pantorrilla corresponde a quiste de Baker roto. El tratamiento es analgesia con AINEs ya que es un cuadro transitorio. Opción C: El quiste de Baker roto no requiere cirugía urgente. El tratamiento es analgesia porque el cuadro es doloroso pero transitorio. La cirugía es excepcional. Opción D: Un hematoma requiere antecedente de trauma o desgarro muscular. El antecedente del bulto previo en la fosa poplítea que desapareció es diagnóstico de quiste de Baker roto. Opción E: El esguince de rodilla requiere traumatismo de la rodilla. El bulto previo en la fosa poplítea y el dolor en la pantorrilla post desaparición del bulto es el cuadro clásico de quiste de Baker roto.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: C**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

1.08.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La opción correcta es la C. Opción A: El grado uno tiene solo dolor sin equimosis ni inestabilidad. La presencia de equimosis e inestabilidad corresponde al grado tres. Opción B: El grado dos tiene rotura parcial con equimosis pero sin inestabilidad articular. La inestabilidad indica rotura total que es grado tres. Opción C: El grado tres tiene rotura total del ligamento con inestabilidad articular más equimosis. El tratamiento es RICE más AINEs más inmovilización con órtesis removible. La cirugía es excepcional. Opción D: El grado tres con inestabilidad es correcto, pero la cirugía no es el tratamiento inicial. El tratamiento es RICE e inmovilización con órtesis. La cirugía se considera solo si hay inestabilidad persistente en el tiempo. Opción E: La equimosis e inestabilidad corresponden a grado tres, no grado uno. Además, siempre se pide radiografía de tobillo para descartar fractura antes de diagnosticar esguince.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

1.08.1.001

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

La opción correcta es la A. En Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES, la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

4.02.1.002

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Tiene una displasia de cadera menor a 9 meses, que se trata con arnés de Pavlik.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: E**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

4.02.1.002

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Menores de 10 meses (según Minsal) o menores de 6 meses (universalmente aceptado) se manejan con correas de Pavlik

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC): Maniobras de Ortolani/Barlow, Screening Ecográfico & Correas de Pavlik GES**

4.02.1.002

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Necrosis avascular de la cabeza femoral en niño 4-10 años + Rx con fragmentación y aplanamiento = enfermedad de Perthes. Derivar a ortopedia para decidir tratamiento conservador vs quirúrgico según clasificación.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: C**

**Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis**

4.02.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tumor óseo de aspecto maligno. Por ubicación y edad es osteosarcoma (adolescentes y adultos mayores). Recordar que Sarcoma de Ewing es diaisiario.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

**Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis**

4.02.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La opción correcta es la B. Opción A: El osteocondroma es benigno con aspecto polipoidea y sin disrupción de la cortical. No tiene invasión de partes blandas ni reacción perióstica compleja. Opción B: El osteosarcoma ocurre en adolescentes y adultos jóvenes con localización metafisiaria. La disrupción de la cortical, invasión de partes blandas y reacción perióstica en sol naciente son signos de malignidad típicos del osteosarcoma. Opción C: El sarcoma de Ewing también ocurre en adolescentes pero su localización más característica es diafisiaria, no metafisiaria. La localización metafisiaria en un adolescente orienta más a osteosarcoma. Opción D: El tumor de células gigantes ocurre en adultos de cuarenta a cincuenta años, no en adolescentes de quince años. La edad y la localización metafisiaria en adolescente apuntan a osteosarcoma. Opción E: El osteoma osteoide es benigno con imagen radiolúcida con halo radiopaco en la cortical, sin disrupción ni invasión de partes blandas. El aspecto maligno de la lesión excluye esta opción.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

**Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis**

4.02.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

La opción correcta es la B. Opción A: El osteosarcoma en adolescentes tiene localización metafisiaria preferentemente, no diafisiaria. La localización diafisiaria en un niño orienta a sarcoma de Ewing. Opción B: El sarcoma de Ewing afecta a niños y adolescentes con localización diafisiaria característica. La lesión maligna en diáfisis de un niño es sarcoma de Ewing hasta que se demuestre lo contrario. Opción C: El tumor de células gigantes afecta a adultos de cuarenta a cincuenta años y se localiza alrededor de la rodilla. No corresponde a un niño de diez años con lesión diafisiaria. Opción D: El osteocondroma es benigno con aspecto polipoidea sin disrupción de la cortical. El aspecto maligno con disrupción y extensión a partes blandas excluye esta opción. Opción E: La enfermedad de Paget es una lesión pseudotumoral de adultos mayores con lesiones en sal y pimienta y fosfatasa alcalina elevada. No corresponde a un niño con lesión diafisiaria maligna.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

**Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteosarcoma (Sol Naciente), Sarcoma de Ewing (Capas de Cebolla) & Metástasis**

4.02.1.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta rara, ya que ni siquiera dicen que hay un tumor, pero reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicas de un tumor maligno. Por la edad, lo más probable es un osteosarcoma. Es frecuente en el Eunacom que se dé el antecedente de trauma (aunque no tenga relación) en distintos tipos de tumores, ya que ahí es que se lo palpan.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: C**

**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

1.10.1.001 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

La opción correcta es la C. Opción A: La resonancia magnética se reserva para lumbagos con signos de alarma: fractura, sospecha de cáncer, infección, espondilitis anquilosante o compromiso neurológico. Este paciente no presenta ninguno de esos signos, por lo que no corresponde solicitarla. Opción B: El reposo en el lumbago mecánico es relativo, no absoluto. El reposo absoluto prolongado tiene un efecto negativo y retrasa la recuperación. El paciente debe mantenerse activo dentro de sus tolerancias. Opción C: El lumbago mecánico sin signos de alarma se maneja con reposo relativo, antiinflamatorios no esteroidales y quinesioterapia. La quinesioterapia se inicia cuando el dolor ha mejorado y va dirigida a fortalecer la musculatura lumbar y abdominal para prevenir recurrencias. Opción D: Los corticoides orales no están indicados en el lumbago mecánico. El tratamiento antiinflamatorio de elección son los AINE. Los corticoides se reservan para algunas situaciones específicas como la capsulitis adhesiva de hombro. Opción E: No hay signos de alarma neurológica en este caso, como debilidad, parestesias o arreflexia. Sin estos hallazgos, no existe indicación de derivación urgente a neurocirugía.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: D**

**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la D. Opción A: La bursitis del olécranon produce inflamación visible en la punta del codo, con eritema y aumento de volumen de la bursa. El dolor a la extensión de la muñeca contra resistencia en la cara lateral del codo es característico de epicondilitis, no de bursitis. Opción B: La epitrocleitis afecta la cara medial del codo y se relaciona con los flexores del antebrazo. El enunciado describe dolor en la cara lateral con movimientos de extensión, lo que corresponde a epicondilitis lateral o codo del tenista. Opción C: La artritis séptica presenta eritema, aumento de volumen articular, fiebre y compromiso sistémico. El enunciado describe dolor crónico sin signos inflamatorios ni sistémicos, lo que descarta esta entidad. Opción D: La epicondilitis lateral afecta la zona de inserción de los extensores del antebrazo en el epicóndilo, produce dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión de muñeca contra resistencia y es frecuente en tenistas. El tratamiento es reposo relativo, AINE, quinesioterapia y el uso de la epicondilera para descomprimir la entesis. Opción E: El síndrome del manguito rotador afecta el hombro, no el codo. La clínica descrita con dolor lateral del codo que aumenta con extensión de muñeca es específica de epicondilitis lateral.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: B**

**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Opción A: La polimialgia reumática cursa con elevación de la VHS y tiene una distribución proximal de los síntomas. En este caso la VHS es normal y hay dolor en puntos gatillo específicos, lo que orienta a fibromialgia. Opción B: La fibromialgia es un diagnóstico clínico basado en dolor a la compresión de los puntos gatillos musculares, astenia y trastornos del sueño, con marcadores inflamatorios normales. El tratamiento de primera línea son los ejercicios de elongación y fortalecimiento, más moduladores del dolor como la pregabalina o los antidepresivos tricíclicos. Opción C: La artritis reumatoide produce artritis simétrica de pequeñas articulaciones, rigidez matutina y marcadores inflamatorios elevados. El enunciado describe dolor muscular en puntos gatillos con marcadores normales, lo que corresponde a fibromialgia. Opción D: La polimiositis cursa con elevación marcada de la creatinkinasa y compromiso muscular proximal con debilidad objetiva, no solo dolor. Los marcadores inflamatorios están alterados. En este caso son normales. Opción E: El lumbago es un dolor lumbar localizado. El enunciado describe dolor en múltiples grupos musculares con puntos gatillos específicos, lo cual es incompatible con lumbago y corresponde al cuadro clínico de fibromialgia.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

1.10.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la A. En Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica), la evaluación neurovascular distal previa y posterior a cualquier inmovilización o reducción es una regla de oro obligatoria.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

4.02.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Lumbalgia mecánica aguda sin alarma: AINEs por corto plazo + actividad física progresiva + kinesioterapia. El reposo en cama prolonga la incapacidad. Sin indicación de imagen en fase aguda.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: E**

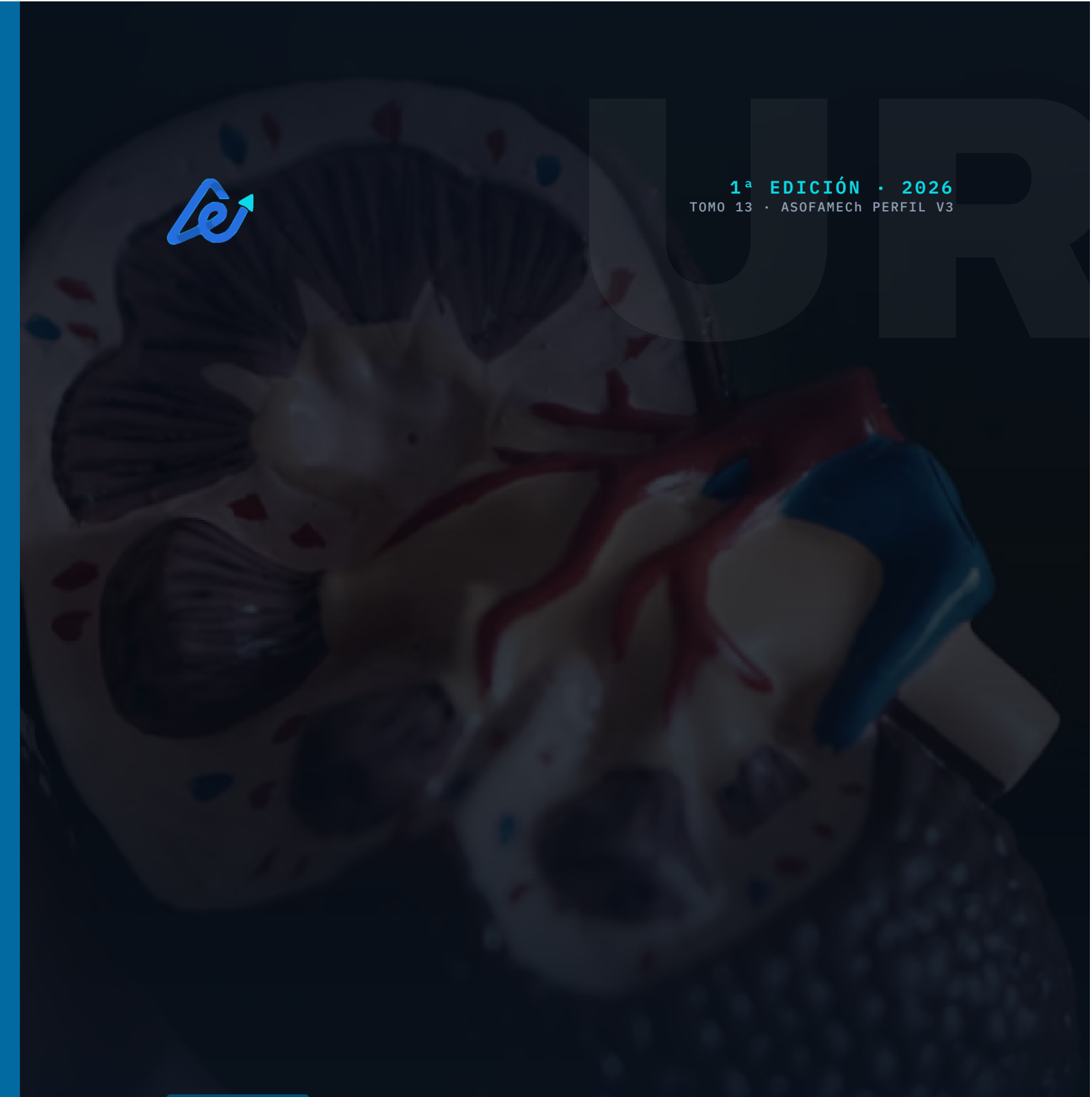
**Lumbago Mecánico vs Inflamatorio, Hernia Discal Lumbar & Síndrome de Cauda Equina (Urgencia Quirúrgica)**

4.02.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es un lumbago mecánico común y corriente (suelen ser muy intensos). Es fundamental la analgesia, el reposo relativo (no en cama) y, una vez que el dolor ha cedido, indicar KNT por largo tiempo, de modo de fortalecer los músculos del core (abdominales, lumbares, multífidos y glúteos), para disminuir las recurrencias.

---

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 13 · ASOFAMECh PERFIL V3



MÓDULO 2

# UROLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Urolitiasis, HPB & Cáncer

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Urología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA** | | | | | |
| 4.01.1.007 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5) |
| 4.01.2.001 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.03.1.001 | Balanitis, balano postitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.009 | Fimosis, parafimosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.013 | Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.015 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q8 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.016 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.025 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.026 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q14 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.027 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q15 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.001 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.003 | Parafimosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.005 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.006 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA** | | | | | |
| 1.04.1.010 | Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33, Q34 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.08.1.009 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24 | Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.1.025 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24 | Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15) |
| 4.01.2.002 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.03.1.004 | Criptorquídea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.007 | Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.012 | Hidronefrosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.014 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.024 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.004 | Priapismo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.007 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO** | | | | | |
| 1.12.1.001 | Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 13 · 13.8 (Pág. 31) |
| 4.01.1.013 | Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53, Q54 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.018 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q40, Q41, Q42 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.03.1.002 | Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.005 | Disfunción sexual de causa orgánica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.011 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q43 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.017 | Infertilidad masculina | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.020 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q44 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.028 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q45 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.008 | Trauma urológico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 4: URO-ONCOLOGÍA** | | | | | |
| 1.12.1.002 | Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 13 · 13.10 (Pág. 37) |
| 4.03.1.003 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.006 | Enfermedades de transmisión sexual | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.010 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.019 | Malformaciones congénitas nefrourológicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.022 | Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 13 · 13.11 (Pág. 41) |
| 4.03.1.023 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71 | Tomo 13 · 13.12 (Pág. 43) |
| 4.03.2.002 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.009 | Traumatismo uretral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57, Q58, Q59 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA** | | | | | |
| 1.07.1.001 | Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87, Q88, Q89, Q90 | Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85) |
| 1.09.1.001 | Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.11.1.006 | Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 13 · 13.13 (Pág. 48) |
| 4.03.1.008 | Estenosis uretral | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.018 | Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q85 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.021 | Reflujo vésico ureteral | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Urología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

**TOMO 13 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO**

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.1.010 | Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33, Q34 | Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35) |
| 1.07.1.001 | Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q86, Q87, Q88, Q89, Q90 | Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85) |
| 1.08.1.009 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24 | Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56) |
| 1.09.1.001 | Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.11.1.006 | Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 13 · 13.13 (Pág. 48) |
| 1.12.1.001 | Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 13 · 13.8 (Pág. 31) |
| 1.12.1.002 | Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q60, Q61, Q62, Q63 | Tomo 13 · 13.10 (Pág. 37) |
| 4.01.1.007 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5) |
| 4.01.1.013 | Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53, Q54 | Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15) |
| 4.01.1.018 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q40, Q41, Q42 | Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32) |
| 4.01.1.025 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q24 | Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15) |
| 4.01.2.001 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q13 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.002 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.03.1.001 | Balanitis, balano postitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.002 | Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.003 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67, Q68 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.004 | Criptorquídea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.1.005 | Disfunción sexual de causa orgánica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.006 | Enfermedades de transmisión sexual | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.007 | Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.008 | Estenosis uretral | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.009 | Fimosis, parafimosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q2 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.010 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.011 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q43 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.012 | Hidronefrosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.013 | Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.014 | Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.015 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q8 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.016 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.017 | Infertilidad masculina | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.018 | Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q85 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.019 | Malformaciones congénitas nefrourológicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.020 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q44 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.021 | Reflujo vésico ureteral | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.022 | Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q64, Q65, Q66 | Tomo 13 · 13.11 (Pág. 41) |
| 4.03.1.023 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70, Q71 | Tomo 13 · 13.12 (Pág. 43) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.03.1.024 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.025 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.026 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q14 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.027 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q15 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.1.028 | Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q45 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.001 | Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.002 | Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.003 | Parafimosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.004 | Priapismo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.005 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.006 | Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.007 | Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.008 | Trauma urológico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |
| 4.03.2.009 | Traumatismo uretral | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57, Q58, Q59 | Tomo 13 · Urología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

PREGUNTA 1 4.03.1.001

**1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Balanitis, balano postitis · 4.03.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Balanitis, balano postitis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 4.03.1.009

**2. Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aplicar ungüento antibiótico

B) Realizar tracción manual forzada del prepucio

C) Realizar circuncisión

D) Aplicar ungüento de corticoide tópico

E) Controlar en un año

PREGUNTA 3 4.03.2.003

**3. [URGENCIA: Parafimosis · 4.03.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Parafimosis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 4 4.01.1.007

**4. Hombre de 35 años consulta a urgencias por dolor lumbar derecho brusco de 2 horas de evolución, irradiado a testículo ipsilateral, acompañado de gran inquietud motora y vómitos. Signos vitales: PA 140/85 mmHg, FC 98 lpm, afebril (36.6 °C). Al examen: abdomen blando sin peritonismo, puñopercusión lumbar derecha dolorosa. Tras administrar ketorolaco EV con excelente alivio del dolor, ¿cuál es el examen de elección para evaluar el tamaño y ubicación exacta del cálculo?**

A) Ecografía renal y vesical con Doppler

B) TAC de abdomen y pelvis sin contraste (Pielotac)

C) Urografía excretora con medio de contraste yodado

D) Radiografía simple de abdomen en bipedestación

E) Resonancia magnética de vías urinarias (Uro-RM)

PREGUNTA 5 4.01.1.007

**5. Mujer de 28 años con diagnóstico tomográfico de litiasis en tercio medio del uréter derecho de 7 mm de diámetro mayor, no obstructiva severa. El dolor fue controlado satisfactoriamente en urgencias. Función renal normal y sedimento sin signos de infección. ¿Cuál es la conducta terapéutica ambulatoria más adecuada?**

A) Observación simple con analgesia a demanda sin fármacos adicionales

B) Terapia médica expulsiva con tamsulosina 0.4 mg/día por hasta 4 semanas

C) Indicación inmediata de litotripsia extracorpórea de urgencia

D) Nefrolitotomía percutánea ambulatoria

E) Instalación de catéter Doble J profiláctico bajo anestesia local

PREGUNTA 6 4.01.1.007

**6. Hombre de 52 años monorreno quirúrgico derecho consulta en el Servicio de Urgencias por dolor lumbar izquierdo sordo y sensación nauseosa de 8 horas de evolución. Refiere que no ha orinado en las últimas 6 horas (anuria confirmada). Exámenes: Creatinina 4.1 mg/dL (basal 1.1 mg/dL), K 5.8 mEq/L. TAC sin contraste revela lito impactado de 9 mm en la unión pieloureteral izquierda con dilatación pielocalicial moderada. ¿Cuál es la conducta prioritaria inmediata?**

A) Infusión endovenosa de 2.000 mL de suero fisiológico para forzar diuresis

B) Hemodiálisis urgente por catéter venoso central y diferir urología

C) Descompresión urológica urgente de la vía urinaria con catéter Doble J o nefrostomía

D) Iniciar tamsulosina 0.4 mg oral y esperar 48 horas de evolución

E) Administrar furosemida 80 mg endovenosa en bolo directo

PREGUNTA 7 4.01.1.007

**7. Paciente de 44 años con antecedentes de tres episodios previos de cólico renal por cálculos de oxalato de calcio. En su estudio metabólico ambulatorio se confirma hipercalciuria idiopática con calcemia y función renal normales. Además de asegurar una ingesta hídrica mayor a 3 litros al día y restricción de sodio, ¿cuál es el fármaco de elección para prevenir nuevas recurrencias?**

A) Alopurinol 300 mg/día
B) Citrato de potasio oral
C) Hidroclorotiazida 25 a 50 mg/día
D) Furosemida 20 mg/día
E) Carbonato de calcio con las comidas

PREGUNTA 8 4.03.1.015

**8. Se a8ende a una paciente de 26 años con antecedente de infecciones del tracto urinario a repe8ción desde hace 4 años, coincidiendo con el inicio de sus relaciones sexuales. Ha presentado urocul8vos posi8vos para Escherichia coli con una frecuencia de 5 a 6 episodios por año. Su examen Fsico actual es normal, el urocul8vo es nega8vo y el panel de PCR para infecciones de transmisión sexual también resulta nega8vo. Una ecograFa renal y vesical previa resultó normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cistoscopía
B) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina
C) Iniciar flavoxato vía oral
D) Profilaxis an2bió2ca poscoital
E) Indicar uso de preserva2vo durante las relaciones sexuales

PREGUNTA 9 4.03.1.016

**9. [ATENCIÓN PRIMARIA: Infección urinaria específica · 4.03.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Infección urinaria específica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 4.03.1.025

**10. Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la ingesta de agua
B) Iniciar alopurinol oral
C) Realizar litrotricia extracorpórea
D) Indicar dieta baja en lácteos
E) Indicar dieta rica en vegetales

PREGUNTA 11 4.03.2.001

**11. Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?**

A) UroTAC
B) PieloTAC
C) Pielografía de eliminación intravenosa
D) Ecografía
E) Radiografía simple

PREGUNTA 12 4.01.2.001

**12. Hombre de 24 años es traído a la urgencia tras sufrir un accidente en motocicleta con impacto en el periné contra el estanque. Al examen físico se observa sangre en el meato uretral (uretrorragia) y un voluminoso hematoma perineal en alas de mariposa. El paciente refiere intensos deseos de orinar pero no lo logra, palpándose un globo vesical a tensión. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para descomprimir la vía urinaria?**

A) Instalar sonda Foley 18 Fr lubricada con lidocaína jalea con técnica estéril
B) Realizar cistostomía suprapúbica percutánea con trocar
C) Indicar analgesia potente y esperar relajación del esfínter externo
D) Intentar cateterismo con sonda nelaton semirrígida de pequeño calibre
E) Administrar tamsulosina oral y solicitar ecografía vesical de rutina

PREGUNTA 13 4.01.2.001

**13. Varón de 69 años con retención urinaria aguda de 12 horas es sondado con éxito en urgencias mediante sonda Foley, evacuándose de forma inmediata 1.400 mL de orina clara. El paciente refiere alivio inmediato del dolor. ¿Cuál es la complicación fisiopatológica que debe monitorizarse con mayor atención en las primeras 24 horas?**

A) Reflejo vasovagal sostenido con paro cardíaco
B) Síndrome de diuresis post-obstructiva con deshidratación e hipokalemia
C) Estenosis uretral isquémica precoz
D) Necrosis tubular aguda anúrica irreversible
E) Hematuria ex vacuo masiva con shock hipovolémico

PREGUNTA 14 4.03.1.026

**14. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía alta · 4.03.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía alta. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 4.03.1.027

**15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Uropatía obstructiva baja · 4.03.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Uropatía obstructiva baja. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.03.2.005

**16. Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es:**

A) Tamsulosina
B) Nitrofurantoína
C) Ciprofloxacino
D) Dutasteride
E) Doxazosina

PREGUNTA 17 4.03.2.006

**17. Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor intenso. ¿Cuál es el manejo inicial de elección?**

A) Sonda Foley vesical
B) Diurético EV
C) Alfa-bloqueador oral y esperar
D) Cistostomía suprapúbica inmediata
E) Cateterismo intermitente

PREGUNTA 18 4.03.1.013

**18. Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Realizar prostatectomía vía resección transuretral
B) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
C) Indicar alfa agonista
D) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa
E) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

## BLOQUE 2 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

PREGUNTA 19 4.03.1.004

**19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Criptorquídea · 4.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Criptorquídea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 4.03.1.012

**20.** **Un paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo, de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo, por lo que se solicita una ecografía abdominal, que muestra una hidronefrosis izquierda, con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación uretral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dl y su sedimento de orina no presenta alteraciones. La cintigrafía renal muestra captación de 90% a derecha y 10% a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar pieloplastía izquierda
B) Realizar nefrostomía percutánea
C) Realizar nefrectomía izquierda
D) Instalar sonda Foley
E) Solicitar pieloTAC

PREGUNTA 21 4.03.2.004

**21.** **Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen se corrobora que tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Aplicar hielo en la zona genital
B) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia
C) Administrar atropina intracavernosa
D) Administrar analgésicos endovenosos
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

PREGUNTA 22 4.01.1.025, 1.08.1.009

**22.** **Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial consulta por escapes urinarios frecuentes. Describe que siente un deseo incontenible de orinar y que 'no alcanza a llegar al baño', perdiendo un volumen importante de orina. Se levanta a orinar 4 veces cada noche. Examen ginecológico sin distopia genital relevante. Sedimento de orina estéril y residuo postmiccional de 20 mL. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más apropiado para su condición?**

A) Instalación de malla suburetral transobturatriz (TOT)
B) Oxibutinina o Mirabegrón oral
C) Cateterismo vesical intermitente cada 6 horas
D) Pseudoefedrina oral 60 mg cada 12 horas
E) Estrógenos locales en crema como monoterapia

PREGUNTA 23 4.01.1.025, 1.08.1.009

**23.** **Hombre de 68 años con diabetes mellitus de 20 años de evolución con neuropatía periférica severa consulta por incontinencia urinaria de 3 meses. Refiere que moja la ropa interior constantemente con un goteo continuo indoloro sin sentir deseos de orinar. El examen físico revela hipoestesia distal en calcetín y una masa blanda palpable en hipogastrio. ¿Cuál es el examen inicial indispensable para orientar el manejo de este paciente?**

A) Cistoscopía diagnóstica de urgencia
B) Medición del residuo postmiccional ecográfico o por cateterismo
C) Urografía retrógrada con contraste
D) Biopsia transrectal de próstata
E) Urodinamia multicanal invasiva de entrada

PREGUNTA 24 4.01.1.025, 1.08.1.009

**24.** **Mujer de 48 años que consulta por incontinencia de esfuerzo. Se le explican los ejercicios de Kegel. ¿En qué consiste exactamente esta técnica kinesiológica?**

A) Pujar repetidamente contrayendo la prensa abdominal mientras se orina
B) Contracciones voluntarias repetidas del músculo pubococcígeo y suelo pélvico sin activar glúteos ni abdomen
C) Aguantar la micción por periodos de más de 8 horas continuas
D) Interrumpir activamente el chorro de orina cada vez que se va al baño a orinar
E) Maniobras de compresión manual suprapúbica para forzar el vaciamiento vesical

PREGUNTA 25 4.03.1.014

**25.** **Una paciente de 60 años presenta incon8nencia urinaria de 2 años de evolución, caracterizada por escapes de orina precedidos por urgencia miccional incontrolable, por lo que u8liza 3 a 5 protectores al día. Su examen Fsico es normal, al igual que su exploración ginecológica. Se solicita una ecograFa abdominal que muestra vía urinaria de calibre normal y vejiga urinaria sin lesiones, con residuo postmiccional de 30 cc. ¿Qué fármaco es más adecuado como tratamiento de primera línea?**

A) Bloqueadores alfa adrenérgicos
B) Bloqueadores beta adrenérgicos
C) Agonistas adrenérgicos
D) An2colinérgicos muscarínicos
E) Estrógenos

PREGUNTA 26 4.01.2.002

**26.** **Niño de 13 años consulta por dolor testicular derecho de inicio brusco e intenso hace 3 horas mientras dormía, acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico: testículo derecho retraído hacia la parte superior del escroto, horizontalizado y muy sensible a la palpación. El reflejo cremastérico derecho está ausente. El centro asistencial no cuenta con ecógrafo disponible en turno de noche. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe adoptarse?**

A) Indicar ketorolaco EV y trasladar en ambulancia para Eco Doppler a un hospital terciario a 2 horas de distancia
B) Exploración quirúrgica inmediata en pabellón por sospecha fundada de torsión testicular
C) Iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona más doxiciclina y citar a control en 24 horas
D) Instalar suspensorio escrotal, aplicar frío local y dar de alta con reposo absoluto
E) Solicitar sedimento de orina y urocultivo antes de decidir interconsulta a urología

PREGUNTA 27 4.01.2.002

**27. Escolar de 9 años es traído por su madre por presentar molestias en el testículo izquierdo de 24 horas de evolución. El dolor es leve a moderado y ha caminado sin dificultad. Al examen físico el testículo izquierdo se palpa de consistencia normal, en posición anatómica eutópica. El reflejo cremastérico está intacto y simétrico bilateralmente. En el polo superior del testículo izquierdo se palpa un nódulo indurado de 4 mm muy sensible, observándose a través de la piel escrotal una pequeña mancha azulada circunscrita. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?**

A) Torsión testicular; exploración quirúrgica urgente
B) Torsión de hidátide de Morgagni; tratamiento médico con reposo y analgésicos AINEs
C) Epididimitis bacteriana; antibioticoterapia con amoxicilina oral por 10 días
D) Orquitis urliana; aislamiento y corticoides sistémicos
E) Tumor testicular de células germinales; orquiectomía inguinal radical

PREGUNTA 28 4.01.2.002

**28. Durante la exploración quirúrgica de urgencia por torsión testicular izquierda en un paciente de 15 años operado a las 8 horas de evolución, el cirujano constata un testículo intensamente congestivo y violáceo. Se realiza la destorsión y tras 15 minutos de compresas tibias, el parénquima recupera una coloración rosada saludable y presenta sangrado rutilante a la mínima incisión de la albugínea. Se fija el testículo al escroto izquierdo. ¿Cuál es el paso quirúrgico indispensable que resta por realizar antes de cerrar la herida?**

A) Realizar biopsia en cuña del testículo izquierdo para certificar viabilidad microscópica
B) Exploración y orquidopexia profiláctica del testículo contralateral derecho
C) Instalación de prótesis testicular protésica inmediata
D) Sección del músculo cremáster derecho a través del conducto inguinal
E) Infiltración del cordón derecho con toxina botulínica

PREGUNTA 29 4.01.2.002

**29. Joven de 16 años ingresa a urgencias con dolor testicular derecho intenso de 1 hora de evolución. Al examen físico se constata testículo derecho horizontalizado y muy sensible. El médico de turno decide intentar una maniobra de destorsión manual mientras se prepara el pabellón. ¿Cuál es la dirección en que habitualmente debe rotarse el testículo derecho para lograr su destorsión?**

A) De lateral hacia medial (hacia la línea media)
B) De medial hacia lateral (hacia el muslo derecho, como abriendo un libro)
C) Tracción axial cefálica firme sin rotación
D) Compresión anteroposterior sostenida durante 2 minutos
E) Rotación de 360 grados en sentido horario estricto

PREGUNTA 30 4.03.1.024

**30. Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al exa- men físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testi- cular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que re- emplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta?**

A) Radioterapia
B) Quimioterapia
C) Orquiectomía radical
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Biopsia testicular por punción

PREGUNTA 31 4.03.2.007

**31. Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Torsión testicular
B) Torsión de la hidátide
C) Infarto testicular
D) Orquiepididimitis
E) Trombosis de varicocele

PREGUNTA 32 1.04.1.010

**32. Hombre de 23 años consulta por dolor testicular derecho progresivo de 3 días de evolución, disuria y febrícula. Al examen físico se constata tumefacción y aumento de volumen del epidídimo derecho, con reflejo cremastérico presente y signo de Prehn positivo. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de primera línea más adecuado para este paciente?**

A) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días en monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única más Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días
C) Nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas por 5 días
D) Azitromicina 500 mg dosis única como tratamiento exclusivo
E) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 14 días

PREGUNTA 33 1.04.1.010

**33. Varón de 64 años con antecedentes de hiperplasia prostática benigna consulta por dolor y aumento de volumen en el hemiescroto izquierdo de 4 días de evolución, acompañado de disuria y fiebre de 38.4 °C. Al examen físico se palpa el testículo y epidídimo izquierdos muy sensibles y engrosados. El sedimento de orina muestra leucocituria abundante y piuria con bacterias móviles. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de su cuadro?**

A) Neisseria gonorrhoeae
B) Chlamydia trachomatis serotipos D-K
C) Escherichia coli
D) Ureaplasma urealyticum
E) Virus de la parotiditis (Paramixovirus)

PREGUNTA 34 1.04.1.010

**34. Hombre de 29 años en tratamiento antibiótico ambulatorio con ceftriaxona y doxiciclina desde hace 4 días por orquiepididimitis derecha. Reconsulta por persistencia de fiebre alta (39 °C), aumento progresivo del tamaño escrotal y dolor pulsátil insoportable. Al examen físico se palpa una zona claramente fluctuante y caliente en la pared posterior del testículo derecho. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica prioritaria?**

A) Aumentar la dosis de doxiciclina y citar en una semana
B) Solicitar ecografía testicular Doppler y derivar a urología para eventual drenaje quirúrgico de un absceso
C) Indicar orquidopexia bilateral inmediata por sospecha de torsión agregada
D) Rotar antibióticos a ciprofloxacino oral y mantener manejo ambulatorio
E) Realizar punción con aguja fina en el box de atención primaria para evacuar el líquido

PREGUNTA 35 4.03.1.007

**35. Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hidrocele
B) Varicocele
C) Torsión testicular
D) Tumor testicular
E) Orquiepididimitis

PREGUNTA 36 4.03.1.007

**36. Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa au- mento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphilococcus aureus
C) Chlamydia trachomatis
D) Neisseria gonorreae
E) Escherichia coli

## BLOQUE 3 URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

PREGUNTA 37 4.03.1.005

**37. Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)
B) Testosterona intramuscular
C) Alprostadil intracavernoso
D) Prótesis de pene
E) Solo consejería psicológica

PREGUNTA 38 4.03.1.017

**38. Un hombre de 33 años, lleva 18 años intentando concebir un hijo con su pareja. Ella tiene reglas regulares y él tiene un examen físico y genital normal. ¿Con qué examen debemos iniciar el estudio en este paciente?**

A) LH
B) FSH
C) Espermiograma
D) Cultivo de líquido seminal
E) Ecografía testicular

PREGUNTA 39 4.03.2.008

**39. Un paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía, evolucionando con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC: 75x' y PA: 120/80 mmHg. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?**

A) PieloTAC
B) UroTAC
C) Radiografía de abdomen simple
D) Ecografía renal
E) Pielografía de eliminación

PREGUNTA 40 4.01.1.018

**40. Hombre de 58 años, previamente sano, consulta por notar hace 3 semanas un aumento de volumen indoloro en el lado derecho del escroto. Al examen físico se constata una masa varicosa tortuosa grado III en el cordón espermático derecho. Al acostar al paciente en decúbito dorsal sobre la camilla, la masa venosa permanece ingurgitada y no colapsa en absoluto. No hay dolor a la palpación. ¿Cuál es la conducta diagnóstica indispensable y prioritaria?**

A) Indicar varicocelectomía subinguinal electiva ambulatoria
B) Solicitar espermiograma completo para evaluar fertilidad
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar masa retroperitoneal o tumor renal
D) Tranquilizar al paciente explicando que es un proceso benigno degenerativo por la edad
E) Indicar uso de suspensorio escrotal elástico y citar en 6 meses

PREGUNTA 41 4.01.1.018

**41.** **Hombre de 32 años consulta por aumento progresivo de volumen del testículo derecho de 6 meses de evolución, sin dolor. Al examen físico se palpa una masa escrotal de 6 cm de diámetro, redondeada, lisa, elástica y no sensible. No es posible individualizar el testículo derecho dentro de la masa. Al apoyar la luz de una linterna en la cara posterior del escroto en penumbra, toda la masa se ilumina con un intenso halo rojo brillante homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tumor testicular de células de Leydig
B) Hidrocele testicular no complicado
C) Varicocele grado III
D) Hernia inguinoescrotal incarcerada
E) Hematoma testicular crónico organizado

PREGUNTA 42 4.01.1.018

**42.** **Pareja de 28 años consulta por infertilidad primaria tras 14 meses de búsqueda sin éxito. El estudio de la mujer es completamente normal. El espermiograma del varón muestra concentración de 8 millones de espermatozoides/mL (oligospermia) con 25% de motilidad progresiva (astenospermia). En el examen físico se palpa un varicocele izquierdo grado II. ¿Cuál es el tratamiento que ha demostrado mayor eficacia para mejorar los parámetros seminales y la fertilidad en este paciente?**

A) Tratamiento con antioxidantes orales y vitamina E por 12 meses
B) Corrección quirúrgica del varicocele (varicocelectomía)
C) Inyecciones semanales de testosterona intramuscular
D) Punción evacuadora con escleroterapia percutánea del plexo
E) Enfriamiento testicular con bolsas de hielo dos veces al día

PREGUNTA 43 4.03.1.011

**43.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hidrocele · 4.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidrocele. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 4.03.1.020

**44.** **Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de díametro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Orquiectomía por vía inguinal
B) Punción y aspiración del quiste
C) Orquiectomía por vía escrotal
D) Observación
E) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

PREGUNTA 45 4.03.1.028

**45.** **Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme.**

A) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
B) Realizar varicosectomía
C) Solicitar espermiograma
D) Realizar biopsia testicular
E) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

PREGUNTA 46 1.12.1.001

**46.** **Hombre de 61 años, asintomático, acude a control de salud. El tacto rectal revela una próstata de volumen normal, sin nódulos ni asimetrías. El informe de laboratorio indica un APE total de 6.2 ng/mL. Se descarta infección urinaria y se repite el examen a las 4 semanas, confirmándose un valor de 6.4 ng/mL con una relación APE libre/total de 9%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A) Indicar tamsulosina 0.4 mg/día y controlar con APE en 1 año
B) Realizar biopsia prostática guiada por ecografía transrectal
C) Solicitar cintigrama óseo de cuerpo entero de entrada
D) Iniciar finasteride 5 mg/día por 6 meses para evaluar si el APE desciende
E) Tranquilizar al paciente indicando que al no haber nódulo palpable no hay riesgo oncológico

PREGUNTA 47 1.12.1.001

**47.** **Varón de 59 años consulta por chequeo prostático. Al tacto rectal se palpa un nódulo indurado pétreo en el lóbulo prostático izquierdo. El APE sérico resulta en 1.9 ng/mL. ¿Cuál es la interpretación clínica y la conducta correcta?**

A) El APE normal descarta cáncer; se debe controlar en 3 años
B) Un nódulo pétreo al tacto rectal obliga a realizar biopsia prostática independiente del APE normal
C) Se debe solicitar relación APE libre/total para decidir si se biopsia
D) Indicar tratamiento antibiótico por 4 semanas por sospecha de prostatitis crónica nodular
E) Solicitar ecografía vesicoprostática simple y dar el alta

PREGUNTA 48 1.12.1.001

**48.** **El informe de anatomía patológica de una biopsia prostática transrectal informa: 'Adenocarcinoma acinar de próstata con patrón Gleason primario 4 en 60% del tejido tumoral y patrón Gleason secundario 3 en 40%'. ¿Cuál es el Score de Gleason y a qué Grupo de Grado ISUP corresponde?**

A) Gleason 3 + 4 = 7; Grupo ISUP 2
B) Gleason 4 + 3 = 7; Grupo ISUP 3
C) Gleason 4 + 4 = 8; Grupo ISUP 4
D) Gleason 3 + 3 = 6; Grupo ISUP 1
E) Gleason 4 + 5 = 9; Grupo ISUP 5

PREGUNTA 49 1.12.1.001

**49.** **En relación con las garantías explícitas en salud para el Cáncer de Próstata en Chile (GES N° 19), ¿cuál es el plazo máximo normado por ley para realizar la confirmación diagnóstica mediante biopsia prostática desde la sospecha clínica fundada?**

A) 10 días corridos
B) 30 días corridos
C) 60 días corridos
D) 90 días corridos
E) 180 días corridos

PREGUNTA 50 4.03.1.002

**50.** **Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Vigilancia activa con control en 3 meses
B) Prostatectomía radical
C) Radioterapia de haz externo
D) Braquiterapia prostática
E) Deprivación androgénica

PREGUNTA 51 4.03.1.002

**51.** **Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como “presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Prostatectomía radical
B) Radioterapia
C) Observar
D) Braquiterapia
E) Hormonoterapia

PREGUNTA 52 4.01.1.013

**52.** **Hombre de 58 años, activo y deportista, con expectativa de vida mayor a 20 años, es diagnosticado de adenocarcinoma prostático ISUP 2 (Gleason 3+4=7) en 4 de 12 cilindros, con APE basal de 7.5 ng/mL y estadio cT1c. El estudio de etapificación con TAC y cintigrama óseo descarta metástasis. ¿Cuáles son las dos opciones terapéuticas estándar con intención curativa recomendadas para este paciente?**

A) Prostatectomía radical o Radioterapia externa conformacional
B) Quimioterapia con docetaxel o Terapia de deprivación androgénica exclusiva
C) Vigilancia activa o Cistectomía radical
D) Resección transuretral de próstata (RTUP) o Tamsulosina oral
E) Inmunoterapia con pembrolizumab o Castración quirúrgica inmediata

PREGUNTA 53 4.01.1.013

**53.** **Varón de 73 años con cáncer de próstata metastásico óseo en columna y pelvis inicia tratamiento con el agonista LHRH Leuprolide intramuscular mensual. ¿Cuál es la razón fisiológica por la que se debe prescribir un antiandrógeno oral (como bicalutamida) durante los primeros 14 días desde la primera inyección?**

A) Prevenir la hepatotoxicidad aguda letal inducida por el leuprolide
B) Bloquear el brote inicial de testosterona ('flare up') que puede exacerbar el dolor óseo y causar compresión medular
C) Acelerar la eliminación renal de los metabolitos del leuprolide
D) Evitar la hiponatremia dilucional por secreción inadecuada de ADH
E) Prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral

PREGUNTA 54 4.01.1.013

**54.** **Paciente de 65 años operado hace 4 meses de prostatectomía radical por adenocarcinoma prostático Gleason 3+4=7 confinado al órgano con márgenes negativos. Consulta en su control postoperatorio por queja de escapes involuntarios de orina al toser, cambiar de posición y caminar rápido, utilizando 2 a 3 absorbentes diarios. El examen neurológico es normal y no hay residuo postmiccional. ¿Cuál es el mecanismo de su incontinencia y la conducta inicial?**

A) Incontinencia de urgencia por vejiga hiperactiva; iniciar oxibutinina oral
B) Incontinencia de esfuerzo por debilidad/lesión esfinteriana; iniciar kinesiterapia del piso pélvico
C) Incontinencia por rebalse; instalar sonda Foley a permanencia
D) Fístula vesicoperineal; indicar cirugía abierta de urgencia
E) Recidiva tumoral retrovesical inmediata; indicar radioterapia pélvica

PREGUNTA 55 4.03.1.006

**55.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedades de transmisión sexual · 4.03.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedades de transmisión sexual. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 4.03.1.019

**56.** **Un recién nacido, con antecedente de pielectasia bilateral, diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina, por lo que se realiza una ecografía abdominal al tercer día de vida, que visualiza hidroureteronefrosis bilateral, asociada a una vejiga de paredes engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Valvas uretrales posteriores
B) Síndrome de Prune Belly
C) Reflujo vésico-ureteral
D) Vejiga neurogénica
E) Megauréter congénito

PREGUNTA 57 4.03.2.009

**57.** **Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B) Solicitar resonancia magnética
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley
E) Instalar cistostomía

PREGUNTA 58 4.03.2.009

**58.** **Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) Uretrocistografía retrógrada
D) Ecotomografía pélvica
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis

PREGUNTA 59 4.03.2.009

**59.** **Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Pielografía de eliminación endovenosa
B) Uretrocistografía retrógrada
C) Cistoscopía
D) TAC de pelvis
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2019 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Pregunta 181) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera?

PREGUNTA 60 1.12.1.002

**60.** **Hombre de 27 años consulta por nódulo palpable indoloro en testículo derecho de 1 mes. La ecografía confirma masa sólida intratesticular de 2.5 cm. Los marcadores séricos muestran AFP 240 ng/mL y b-hCG normal. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico y la conducta inicial correcta?**

A) Biopsia con aguja gruesa a través de la piel del escroto bajo anestesia local
B) Orquiectomía radical por abordaje inguinal con clampeo alto del cordón espermático
C) Enucleación simple del nódulo por incisión escrotal con biopsia rápida
D) Observación con ecografía seriada en 3 meses para evaluar crecimiento
E) Quimioterapia con bleomicina antes de cualquier procedimiento quirúrgico

PREGUNTA 61 1.12.1.002

**61.** **En un paciente de 30 años con masa testicular resecada mediante orquiectomía inguinal, el informe preliminar de biopsia describe 'Seminoma clásico puro'. Sin embargo, los exámenes de sangre preoperatorios y postoperatorios demuestran persistentemente una Alfafetoproteína (AFP) de 350 ng/mL (valor normal < 8 ng/mL). ¿Cuál es la implicancia clínica de este hallazgo?**

A) El diagnóstico es correcto, ya que el 50% de los seminomas puros secretan AFP
B) El seminoma puro NUNCA produce AFP; la elevación de AFP descarta seminoma puro y obliga a tratar al paciente como un No Seminoma
C) La AFP elevada se debe a necrosis tumoral y no modifica la conducta terapéutica del seminoma
D) La elevación de AFP indica únicamente insuficiencia hepática secundaria a fármacos anestésicos
E) Indica que el paciente tiene un teratoma benigno maduro sin potencial invasor

PREGUNTA 62 1.12.1.002

**62.** **Hombre de 22 años operado de orquiectomía inguinal derecha por tumor no seminomatoso. El TAC de tórax, abdomen y pelvis no muestra adenopatías ni lesiones a distancia. Antes de iniciar la quimioterapia adyuvante protocolizada, ¿cuál es la medida preventiva de soporte que debe ofrecerse obligatoriamente al paciente?**

A) Criopreservación de semen en banco de esperma
B) Vacunación antineumocócica conjugada
C) Suplementación con testosterona intramuscular mensual
D) Instalación de reservorio venoso subcutáneo profiláctico
E) Nefrectomía profiláctica ipsilateral

PREGUNTA 63 1.12.1.002

**63.** **¿Cuál de los siguientes factores constituye el factor de riesgo mejor establecido para el desarrollo de cáncer testicular de células germinales?**

A) Varicocele izquierdo de larga data
B) Criptorquidia o testículo no descendido
C) Infección urinaria recurrente en la infancia
D) Uso prolongado de ropa interior ajustada
E) Traumatismos testiculares a repetición en deportistas

PREGUNTA 64 4.03.1.022

**64.** **Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Nefrectomía radical
B) Nefrectomía parcial
C) Nefroureterectomía
D) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
E) Realizar seguimiento ecográfico

PREGUNTA 65 4.03.1.022

**65.** **Mujer de 53 años consulta por control ginecológico. En la ecografía pelviana y abdominal de rutina se describe en el riñón derecho una lesión sólida hiperecogénica exofítica de 3.2 cm en el polo inferior. La paciente está asintomática. ¿Cuál es el examen confirmatorio de elección para caracterizar la lesión y planificar la conducta?**

A) Biopsia renal percutánea con aguja de corte bajo ecografía
B) TAC de abdomen y pelvis trifásico con contraste endovenoso
C) Resonancia magnética con difusión sin contraste
D) Cistoscopía diagnóstica con citología de orina de lavado piélico
E) Cintigrama renal con DMSA para evaluar función relativa

PREGUNTA 66 4.03.1.022

**66.** **Hombre de 60 años con diagnóstico tomográfico de carcinoma renal de células claras de 3.8 cm en el tercio medio exofítico del riñón derecho, sin metástasis. Presenta creatinina normal y no tiene comorbilidades graves. ¿Cuál es el tratamiento curativo de elección recomendado actualmente por las guías urológicas y el GES N° 76?**

A) Nefrectomía radical derecha con vaciamiento ganglionar extenso
B) Nefrectomía parcial derecha nefro-preservadora
C) Radioterapia estereotáctica corporal ablativa (SBRT)
D) Terapia blanco con sunitinib oral durante 6 meses
E) Embolización arterial renal percutánea curativa

PREGUNTA 67 4.03.1.003

**67.** **Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:**

A) Cistitis hemorrágica
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer renal.
D) Tuberculosis renal
E) Infección urinaria

PREGUNTA 68 4.03.1.003

**68.** **Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin**

A) Cáncer renal
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer de uréter
D) Cáncer de próstata
E) Cistitis intersticial

PREGUNTA 69 4.03.1.010

**69.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hematuria · 4.03.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hematuria. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 70 4.03.1.023

**70.** **Hombre de 67 años, fumador inveterado, consulta por dos episodios de orina con sangre roja y coágulos en la última semana, sin ningún tipo de dolor ni molestia miccional. El examen físico general y urológico no muestra alteraciones. El sedimento descarta infección urinaria. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para visualizar directamente la lesión y confirmar la sospecha de cáncer de vejiga?**

A) Urografía retrógrada con placa postmiccional
B) Cistoscopía con eventual resección transuretral de la lesión
C) Antígeno prostático específico y ecografía prostática transrectal
D) Resonancia magnética pélvica simple
E) Citología urinaria seriada como método diagnóstico exclusivo

PREGUNTA 71 4.03.1.023

**71.** **Tras realizar una resección transuretral de vejiga (RTUV) de una masa vegetante en la pared lateral vesical en un paciente de 62 años, el patólogo informa: 'Carcinoma urotelial de alto grado que infiltra la lámina propia pero respeta la capa muscular propia; se identifican haces indemnes de músculo detrusor en la muestra (Estadio T1)'. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante de elección para reducir el riesgo de recidiva y progresión?**

A) Cistectomía radical inmediata con conducto ileal de Bricker
B) Instilaciones intravesicales con BCG (Bacilo de Calmette-Guérin)
C) Radioterapia externa pélvica conformacional
D) Quimioterapia sistémica con esquema MVAC por 6 ciclos
E) Observación sin terapia adicional con control cistoscópico en 5 años

PREGUNTA 72 4.03.2.002

**72.** **[URGENCIA: Hematuria masiva · 4.03.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hematuria masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

## BLOQUE 5 INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA

PREGUNTA 73 4.03.1.008

**73.** **Un paciente masculino, de 30 años, consulta por diminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años atrás. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de próstata
B) Uretritis
C) Hiperplasia prostática benigna
D) Estenosis uretral
E) Urolitiasis

PREGUNTA 74 4.03.1.021

**74.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Reflujo vésico ureteral · 4.03.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Reflujo vésico ureteral. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 75 1.11.1.006

**75. Hombre de 42 años consulta por cuadro de 24 horas de fiebre de 39.5 °C, calofríos, dolor perineal sordo que empeora al sentarse y disuria. Al tacto rectal suave se palpa una próstata caliente, tumefacta y extremadamente dolorosa. ¿Cuál de las siguientes acciones está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en el manejo de este paciente?**

A) Tomar urocultivo por chorro medio antes de iniciar antibióticos
B) Realizar masaje prostático vigoroso para obtener secreción uretral diagnóstica
C) Administrar antipiréticos y AINEs para el alivio del dolor
D) Indicar ciprofloxacino oral por 4 semanas completas
E) Realizar cistostomía suprapúbica si presenta retención aguda de orina

PREGUNTA 76 1.11.1.006

**76. Varón de 50 años con diagnóstico clínico de prostatitis bacteriana aguda que se encuentra hemodinámicamente estable y tolerando adecuadamente la vía oral. Se inicia tratamiento con ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la duración mínima recomendada de este tratamiento antibiótico para asegurar la erradicación bacteriana y prevenir la prostatitis crónica?**

A) 3 a 5 días
B) 7 a 10 días
C) 21 a 28 días (3 a 4 semanas)
D) 6 meses ininterrumpidos
E) Hasta 48 horas después de que ceda la fiebre

PREGUNTA 77 1.11.1.006

**77. En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 78 1.11.1.006

**78. En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 79 1.11.1.006

**79. En el enfrentamiento clínico sistemático de Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 1.09.1.001

**80. Mujer de 54 años asintomática se realiza una ecografía abdominal como parte de un chequeo preventivo. El informe describe: 'En polo superior del riñón izquierdo se observa lesión anecogénica de 3.8 cm, redondeada, de paredes delgadas e imperceptibles, con refuerzo acústico posterior nítido y sin tabiques ni calcificaciones internas'. Examen físico y función renal normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a la paciente y darle el alta sin necesidad de seguimiento
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar malignidad
C) Programar punción percutánea aspirativa del quiste para análisis citológico
D) Repetir ecografía renal cada 6 meses por 3 años consecutivos
E) Derivar a urología para quistectomía laparoscópica electiva

PREGUNTA 81 1.09.1.001

**81. Hombre de 35 años con diagnóstico de Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) e hipertensión arterial en tratamiento consulta en urgencias por cefalea súbita e hiperaguda de máxima intensidad ('la peor cefalea de su vida'), acompañada de vómitos explosivos y rigidez de nuca. ¿Cuál es la complicación vascular subyacente más probable que explica este cuadro?**

A) Trombosis de la vena renal bilateral
B) Rotura de aneurisma sacular intracraneal del polígono de Willis con hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopatía hipertensiva con microhemorragias pontinas
D) Rotura de quiste renal infectado con shock séptico
E) Disección de aorta torácica tipo A

PREGUNTA 82 1.09.1.001

**82. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 83 1.09.1.001

**83. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 84 1.09.1.001

**84. En el enfrentamiento clínico sistemático de Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 85 4.03.1.018

**85. [ATENCIÓN PRIMARIA: Lesiones quísticas del riñón · 4.03.1.018] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Lesiones quísticas del riñón. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 86 1.07.1.001

**86. Hombre de 24 años consulta por orinas oscuras tipo 'coca-cola' tras un cuadro de faringoamigdalitis hace 12 días. Al examen físico: PA 148/94 mmHg y leve edema bipalpebral. El sedimento de orina revela abundantes glóbulos rojos con 85% de formas dismórficas, acantocitos en 8% y cilindros hemáticos. Proteinuria de 1.2 g/24 horas. ¿Cuál es el origen de la hematuria y el paso siguiente más adecuado?**

A) Origen urológico; solicitar Uro-TAC con contraste urgente
B) Origen glomerular; derivar a nefrología para estudio de síndrome nefrítico
C) Origen prostático; iniciar tamsulosina oral y solicitar APE
D) Infección urinaria baja; indicar ciprofloxacino por 14 días
E) Litiasis ureteral silente; indicar abundante hidratación y analgesia

PREGUNTA 87 1.07.1.001

**87. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio en un paciente con hematuria permite descartar con mayor certeza el origen glomerular del sangrado?**

A) Presencia de coágulos sanguíneos macroscópicos en la orina emitida
B) Orina de aspecto turbio y espumoso
C) Presencia de hipertensión arterial asociada
D) Microhematuria aislada sin proteinuria
E) Aparición de hematuria posterior a ejercicio extenuante

PREGUNTA 88 1.07.1.001

**88. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 89 1.07.1.001

**89. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 90 1.07.1.001

**90. En el enfrentamiento clínico sistemático de Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A — Balanitis, balano postitis

4.03.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Balanitis, balano postitis" (4.03.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 2 Respuesta: D — Fimosis, parafimosis

4.03.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 114). Evalúa el manejo clínico de Fimosis, parafimosis según directrices MINSAL vigentes.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A — Parafimosis

4.03.2.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Parafimosis" como urgencia clínica (4.03.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 4 Respuesta: B

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El TAC de abdomen y pelvis sin contraste (Pielotac) es el estándar de oro para el estudio de la litiasis urológica. Posee una sensibilidad y especificidad >98%, permitiendo visualizar cálculos de cualquier tamaño y composición (incluso los de ácido úrico que son radiolúcidos en radiografía simple). Permite medir con precisión milimétrica el lito y objetivar el grado de hidronefrosis para definir si corresponde manejo expectante o intervención urológica. Perla. La ecografía renal tiene menor rendimiento para litiasis ureterales intermedias y se reserva para embarazadas.

### PREGUNTA 5 Respuesta: B

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Los cálculos ureterales entre 5 y 10 mm presentan una probabilidad intermedia de eliminación espontánea. La guía clínica internacional y nacional recomienda el uso de Terapia Médica Expulsiva (TME) mediante alfa-1 bloqueantes como Tamsulosina (0.4 mg una vez al día) durante un periodo de 2 a 4 semanas. Este fármaco relaja el músculo liso ureteral distal, duplicando la tasa de expulsión y reduciendo significativamente los requerimientos de analgesia de rescate. Perla. Si al cabo de 4 semanas no se ha expulsado el lito, se programa resolución quirúrgica activa.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: C**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una Injuria Renal Aguda postrenal anúrica en un riñón único funcionante. Esto constituye una emergencia urológica absoluta que amenaza de forma inminente la vida y la sobrevida del parénquima renal. La conducta mandatoria es la descompresión urgente de la vía urinaria mediante la colocación retrógrada de un catéter Doble J o la punción anterógrada de una nefrostomía percutánea. Trampa. La infusión de fluidos masivos o diuréticos de asa en una vía urinaria obstruida está contraindicada porque provoca edema pulmonar agudo y mayor daño glomerular.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: C**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La hidroclorotiazida (diurético tiazídico) es el tratamiento farmacológico de primera línea en la urolitiasis cálcica recidivante asociada a hipercalciuria idiopática. Las tiazidas estimulan la reabsorción activa de calcio en el túbulo contorneado distal, disminuyendo significativamente la concentración de calcio en la orina y evitando la sobresaturación de sales de oxalato. Adicionalmente, confiere protección mineral ósea. Perla. La furosemida por el contrario es calciúrica y aumentaría la formación de litos.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: D**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.03.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Las ITU recurrentes se deben 1. Confirmar con urocultivo, 2. Estudiar en búsqueda de una causa tratable y 3. Manejar con profilaxis antibiótica, hasta resolver la causa de base. Si hay clara relación con acGvidad sexual, la profilaxis antibiótica poscoital disminuye las recurrencias.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.03.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Infección urinaria específica" (4.03.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.03.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalciuria, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

**Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea**

4.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El cólico renal se estudia con PieloTAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presencia de uretrorragia y hematoma perineal en mariposa tras trauma pélvico o perineal es patognomónica de rotura de uretra (generalmente bulbar o membranosa). En este escenario, el cateterismo vesical a ciegas con sonda Foley está formalmente contraindicado porque puede convertir una rotura parcial en una sección uretral completa o provocar falsas vías e infección masiva. La conducta de elección inmediata para resolver la retención urinaria es la cistostomía suprapúbica por punción. Perla. El estudio posterior de la rotura se realiza con uretrocistografía retrógrada.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tras la descompresión rápida de una obstrucción urinaria severa y prolongada (especialmente con volúmenes > 1.000 mL), puede desencadenarse el síndrome de diuresis post-obstructiva. Se produce por la pérdida del gradiente de concentración medular, la excreción forzada de urea retenida y la insensibilidad tubular transitoria a la ADH, pudiendo generar diuresis masiva (> 200 mL/h) con deshidratación grave, hiponatremia o hipokalemia si no se reponen parcialmente las pérdidas hidrosalinas. Perla. La hematuria ex vacuo es un evento benigno autolimitado.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.03.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía alta" (4.03.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.03.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Uropatía obstructiva baja" (4.03.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La sospecha es una prostatitis aguda, por la clínica de ITU e importante elevación del APE. Se trata con ciprofloxacino. Se puede estudiar con cultivo de líquido seminal. Luego de tratarla, se debe esperar a repetir el APE.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

**Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía**

4.03.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Retención urinaria aguda: manejo inmediato = sonda Foley para drenaje vesical. Alivia el dolor y previene daño renal. Cistostomía solo si falla la sonda. Alfa-bloqueador se agrega DESPUÉS del episodio agudo para prevención de recurrencia.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: A**

**Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP**

4.03.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Primero se deben indicar alfa-ANTAgonistas, porque no hay ninguna indicación estricta de cirugía. Pero de las opciones que aparecen la RTU es la única aceptable (aunque no se dice el tamaño de la próstata, porque si es mayor a 60cc, se debe hacer cirugía abierta y no RTU). Los inhibidores de la 5 alfa reductasa no sirven. La biopsia solo está indicada si TR positivo o APE mayor a 4 o velocidad de APE mayor a 0,75.

---

## BLOQUE 2 UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 19 **Respuesta: A** Criptorquídea

4.03.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Criptorquídea" (4.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

### PREGUNTA 20 **Respuesta: C** Hidronefrosis

4.03.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta muy discutible y de manejo de especialista, que no debería preguntarse. Que tenga solo 10% de captación y adelgazamiento cortical muestra que el riñón probablemente tiene daño severo e irrecuperable, por lo que estaría indicada la nefrectomía. Eso sí, antes debería pedirse una TAC, ya que igual se puede intentar salvar ese 10% con una pieloplastía. Discutimos mucho esta pregunta con varios especialistas y aunque no hubo consenso, dejaremos como correcta la nefrectomía. Nuevamente, en fin... así es el Eunacom y lo más importante es no pelear con él, sino seguir respondiendo.

---

### PREGUNTA 21 **Respuesta: E** Priapismo

4.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

El priapismo isquémico (erección dolorosa y mayor a 4 horas, que suele perder la turgencia del glande y cuerpo esponjoso) es una urgencia y se maneja en primer lugar con fenilefrina intracavernosa, seguido luego de manejo invasivo con drenaje y lavado con SF de los cuerpos cavernosos y, si falla, con derivación cavernoesponjosa. También se deben buscar causas secundarias (ej. drepanocitosis o leucemia) y, además, distinguirlo del priapismo de alto flujo o no isquémico (que es por hiperflujo arterial y generalmente no duele ni tiene riesgo de complicarse con disfunción eréctil permanente, por lo que se observa o maneja con compresas de hielo para acelerar su desaparición).

---

### PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

**Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica**

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El cuadro clínico corresponde a una Incontinencia Urinaria de Urgencia en el contexto de un Síndrome de Vejiga Hiperactiva, caracterizado por contracciones no inhibidas del detrusor con residuo postmiccional normal. El tratamiento farmacológico de primera línea consiste en antimuscarínicos (como Oxibutinina o Tolterodina) o en el agonista beta-3 adrenérgico Mirabegrón (preferido en pacientes geriátricos por su menor perfil de efectos anticolinérgicos centrales). La cirugía con cabestrillo (TOT) está reservada para la incontinencia de esfuerzo y no tiene utilidad en este cuadro.

---

### PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

**Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica**

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta el cuadro clásico de Incontinencia Urinaria por Rebalse secundaria a vejiga neurógena diabética atónica (cistopatía diabética). La denervación autonómica sensitiva impide censar el llenado vesical, llevando a sobredistensión crónica y goteo por rebalse. El examen no invasivo inicial indispensable es la medición del Residuo Postmiccional (RPM), el cual típicamente estará marcadamente elevado (> 300-500 mL), confirmando la falla de vaciamiento y previniendo la prescripción errónea de anticolinérgicos.

---

### PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

**Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica**

4.01.1.025, 1.08.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Los ejercicios de Kegel consisten en la contracción voluntaria, aislada y repetida de los músculos del suelo pélvico (principalmente el complejo elevador del ano y pubococcígeo) sin contraer simultáneamente la musculatura de la pared abdominal anterior, los glúteos ni los aductores. Se deben realizar en series diarias programadas fuera de la micción. Perla. Interrumpir el chorro miccional al orinar ('stop-flow') no debe usarse como ejercicio regular porque altera el reflejo miccional normal y predispone a infecciones.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: D**

4.03.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica**

Tiene una inconGnencia de urgencia. Se trata con medidas de conductuales y de reeducación vesical más kinesioterapia pélvica. De segunda línea, se pueden usar fármacos. Los más usados son los anticolinérgicos (oxibuGnina, tolterodina, cloruro de trospio), por lo que los dejaremos como respuesta correcta. Sin embargo, los agonistas beta 3 adrenérgicos (vivegrón y miravegrón) son una excelente y segura opción, aunque son caros y están poco disponibles en Chile. En adultos mayores, los anticolinérgicos se asocian a desarrollo y agravamiento de demencia, por lo que se prefiere el cloruro de trospio (traspasa menos la barrera hematoencefálica) y o los beta 3 adrenérgicos.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

La clínica descrita es categórica de Torsión Testicular: paciente en grupo etario de máxima incidencia, inicio brusco nocturno, cortejo vegetativo, signo de Gouverneur positivo y reflejo cremastérico ausente. El tiempo de isquemia transcurrido es de apenas 3 horas (dentro de la ventana de máxima viabilidad < 6 horas). Ante alta sospecha clínica, NUNCA se debe postergar la cirugía ni perder tiempo valioso trasladando al paciente para una ecografía; la conducta obligatoria es la exploración quirúrgica inmediata. Perla. Trasladar al paciente costaría horas críticas de viabilidad.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

El cuadro clínico es el prototipo de una Torsión de Apéndice Testicular (Hidátide de Morgagni): dolor moderado subagudo en escolar, reflejo cremastérico conservado, testículo en posición normal y el signo patognomónico del 'punto azul' (blue dot sign), correspondiente al apéndice isquémico trombosado visible por transparencia en el polo superior. Esta patología es autolimitada y no pone en riesgo la viabilidad de la gónada; su tratamiento de elección es conservador con reposo y antiinflamatorios no esteroidales (AINEs). Perla. La cirugía se reserva solo para casos atípicos donde no se logre descartar torsión de cordón.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

En toda intervención por torsión testicular, la fijación del testículo contralateral (orquidopexia profiláctica contralateral) es un paso quirúrgico formalmente obligatorio y de estándar legal. La anomalía anatómica que predispone a la torsión (la fijación alta de la túnica vaginal o deformidad en 'badajo de campana') es una condición congénita bilateral en más del 80% de los casos. Omitir la orquidopexia contralateral deja al paciente en riesgo latente de torsión del único testículo remanente o sano en el futuro, con riesgo de anorquia e infertilidad.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

La inmensa mayoría de las torsiones testiculares (> 80%) ocurren en dirección medial (hacia la línea media del cuerpo). Por esta razón, la maniobra de destorsión manual externa consiste en rotar el testículo en sentido opuesto: de medial hacia lateral, lo que mnemotécnicamente se describe como 'abrir las páginas de un libro' (para el testículo derecho, en sentido antihorario; para el izquierdo, en sentido horario). Si la maniobra es exitosa, el paciente experimenta un alivio dramático inmediato del dolor; no obstante, la exploración quirúrgica para orquidopexia bilateral sigue siendo mandatoria.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: C**

4.03.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

Es un tumor testicular, confirmado con la ecografía, por lo que se debe realizar la orquiectomía radical, con biopsia excisional.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: A**

4.03.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h**

Cuadro clásico. Que sea adolescente orienta aún más a torsión testicular, por sobre el de hidátide (niños más chicos).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

**Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En hombres menores de 35 años sexualmente activos, la orquiepididimitis aguda es causada fundamentalmente por patógenos de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. El esquema antibiótico normado de primera línea consiste en la combinación de Ceftriaxona (500 mg o 1 g IM en dosis única para cubrir el gonococo) asociada a Doxiciclina (100 mg cada 12 horas oral por 10 a 14 días para erradicar Chlamydia). Además se debe tratar a la pareja sexual. Perla. El ciprofloxacino no cubre adecuadamente Chlamydia ni gonococo por alta tasa de resistencia.

**PREGUNTA 33** **Respuesta: C**

**Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En hombres mayores de 35 años, y particularmente en aquellos con patología prostática de base (HPB), obstrucción urinaria baja o instrumentación urológica, la orquiepididimitis se produce por el reflujo retrógrado de orina infectada desde la uretra prostática hacia los conductos eyaculadores y deferentes. En este grupo etario, el microorganismo causante en más del 80% de los casos son las enterobacterias gramnegativas del tracto digestivo, lideradas ampliamente por Escherichia coli.

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

**Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo**

1.04.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La persistencia de fiebre alta, empeoramiento clínico y aparición de una zona fluctuante en el escroto tras 72-96 horas de antibioticoterapia adecuada es altamente sugerente de una complicación supurativa mayor: un **absceso epididimario o testicular**. La conducta mandatoria es confirmar la colección purulenta mediante Ecografía Doppler escrotal urgente y derivar al especialista en urología para hospitalización, antibioticoterapia parenteral de amplio espectro y drenaje quirúrgico o eventual orquiectomía si el parénquima está destruido.

**PREGUNTA 35** **Respuesta: E**

**Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo**

4.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una orquiepididimitis clásica.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: E**

**Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo**

4.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

E? La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gono- rrea (yo marqué Chlamydia). Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayo- res. En este caso, si le creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli.

## BLOQUE 3 URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

**Disfunción sexual de causa orgánica**

4.03.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Disfunción eréctil: primera línea = inhibidores de PDE5 (sildenafil, tadalafil). Contraindicados con nitratos. Enalapril no contraindica su uso. La testosterona solo si hay hipogonadismo confirmado.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: C** **Infertilidad masculina**

4.03.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

El primer estudio de infertilidad masculina es el espermiograma.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B** Trauma urológico

4.03.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un traumatismo renal (golpe lumbar más hematuria), que se estudia con el Uro TAC. No confundir con la lesión uretral (golpe pélvico más uretrorragia), que se estudia con la UCG.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hallazgo de un varicocele del lado derecho (sitio altamente infrecuente), de aparición tardía en un adulto de 58 años y que característicamente no se colapsa en posición de decúbito dorsal, es un signo de alarma mayor de obstrucción vascular retroperitoneal fija. La causa más temida es un Carcinoma de Células Renales con invasión y trombo tumoral de la vena cava inferior o una compresión tumoral retroperitoneal sobre el drenaje venoso espermático. La conducta obligatoria e inmediata es descartar neoplasia mediante un TAC de abdomen y pelvis con contraste.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La presencia de una masa escrotal indolora, fluctuante, que engloba por completo al testículo impidiendo su palpación aislada y que presenta una prueba de transiluminación intensamente positiva es patognomónica de un **Hidrocele** (acumulación de líquido seroso claro entre las capas de la túnica vaginal). Los tumores sólidos testiculares, las hernias y los hematoceles son opacos a la luz y arrojan transiluminación negativa.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El varicocele clínico palpable asociado a alteración documentada del espermiograma (oligoastenoteratozoospermia) en el contexto de infertilidad de pareja es la indicación formal y de primera línea para la reparación quirúrgica (**Varicocelectomía** microquirúrgica subinguinal o laparoscópica). La ligadura de las venas espermáticas dilatadas disminuye la hipertermia y el estrés oxidativo intratesticular, logrando una mejoría significativa de la concentración y movilidad espermática en más del 60-70% de los pacientes tratados, con aumento de las tasas de embarazo espontáneo. Perla. El uso de testosterona exógena suprime el eje y empeora la infertilidad produciendo azoospermia.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.03.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidrocele" (4.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: D**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un quiste del epidídimo. Se observan.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

**Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes**

4.03.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene indicación de ligadura del plexo pampiniforme, tanto por la atrofia testicular, como por el dolor.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

El paciente presenta un APE total confirmado en la 'zona gris' (4.0 a 10.0 ng/mL) con tacto rectal normal. En este rango, el porcentaje de APE Libre/Total es la herramienta de discriminación más útil: un valor inferior al 15% (en este caso 9%) se asocia a un riesgo de cáncer de próstata superior al 50-60%. La conducta oficial de elección es la confirmación histológica mediante biopsia prostática guiada por ecografía transrectal (GES N° 19). Perla. Iniciar finasteride en este momento enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

Esta es una de las reglas de oro más repetidas en el examen EUNACOM: el Tacto Rectal y el APE son métodos complementarios y mutuamente independientes. Hasta un 20% de los adenocarcinomas de próstata clínicamente significativos no elevan el APE por encima de 4.0 ng/mL (especialmente tumores muy indiferenciados o localizados). La presencia de un nódulo duro o pétreo al tacto rectal es una indicación absoluta de biopsia prostática transrectal ecoguiada, independientemente de que el APE sea bajo o normal.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

El score de Gleason se formula sumando primero el patrón arquitectural más frecuente (en este caso el patrón 4, presente en el 60%) seguido del segundo patrón más frecuente (patrón 3, en el 40%), resultando en Gleason 4 + 3 = 7. De acuerdo a la clasificación internacional de la ISUP, el Gleason 4+3 corresponde al Grupo de Grado ISUP 3 (pronóstico desfavorable intermedio), diferenciándose críticamente del Gleason 3+4 (ISUP 2), que posee un curso biológico mucho más favorable. Perla. El primer número siempre representa el patrón predominante.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

1.12.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

La Guía Clínica AUGE / GES N° 19 establece taxativamente que todo paciente de 15 años y más con sospecha fundada de cáncer de próstata (por tacto rectal sospechoso o APE elevado persistente) tiene derecho legal a la confirmación diagnóstica mediante biopsia dentro de un plazo máximo de 30 días desde la derivación con sospecha. Una vez confirmada la biopsia, el tratamiento curativo o paliativo debe iniciarse dentro de los 60 días.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

4.03.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

Vigilancia activa con control en 3 meses

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: C**

4.03.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason**

Caso clínico oficial EUNACOM para Cáncer de próstata.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: A**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)**

En el cáncer de próstata localizado de riesgo intermedio favorable (ISUP 2, Gleason 3+4, APE < 10) en un paciente joven con excelente estado basal y expectativa de vida prolongada (> 10-15 años), las dos alternativas terapéuticas de referencia con demostrada intención curativa y sobrevida global equivalente a 10 y 15 años son la **Prostatectomía Radical** (con o sin preservación de bandeletas neurovasculares) y la **Radioterapia Externa** (asociada o no a hormonoterapia corta). La elección entre ambas depende de la preferencia informada del paciente respecto a los perfiles de efectos secundarios (incontinencia/disfunción eréctil vs toxicidad rectal/urinaria).

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Los agonistas del receptor de GnRH/LHRH (como leuprolide y goserelina) estimulan inicialmente los receptores hipofisarios de forma potente antes de producir su internalización y desensibilización (down-regulation). Durante los primeros 7 a 14 días se produce una elevación transitoria de LH y consecuentemente un aumento en la síntesis de testosterona, fenómeno conocido como **'flare up' tumoral**. En pacientes con metástasis óseas vertebrales, este aumento puede provocar una rápida progresión tumoral con dolor óseo intolerable, retención urinaria o compresión medular aguda. La coadministración de un antiandrógeno periférico (Bicalutamida) bloquea los receptores androgénicos prostáticos y neutraliza este riesgo.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: B**

**Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)**

4.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La incontinencia urinaria post-prostatectomía radical es predominantemente una Incontinencia Urinaria de Esfuerzo secundaria a la alteración o daño por tracción del esfínter uretral estriado y pérdida del soporte anatómico uretral. En los primeros 6 a 12 meses postoperatorios, la inmensa mayoría de los pacientes experimenta una mejoría progresiva sustancial. La conducta inicial obligatoria es la rehabilitación y fortalecimiento del esfínter mediante **kinesiterapia del suelo pélvico** supervisada. La colocación de un esfínter urinario artificial solo se considera tras al menos 1 año de evolución si la incontinencia persiste severa.

---

## BLOQUE 4 URO-ONCOLOGÍA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A**

**Enfermedades de transmisión sexual**

4.03.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedades de transmisión sexual" (4.03.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Malformaciones congénitas nefrourológicas**

4.03.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La dilatación bilateral, más la vejiga de lucha orienta a obstrucción uretral. La única opción era la de las valvas/válvulas uretrales, que son una malformación relativamente frecuente.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: E** **Traumatismo uretral**

4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una sección uretral. Está contraindicada la Sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámens que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: C** **Traumatismo uretral**

4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La sospecha es una sección uretral, por lo que se contraindica la sonda Foley, se estudia con UCG retrógrada, se maneja con cistostomía suprapúbica y, además, con cirugía de reparación uretral.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B** **Traumatismo uretral**

4.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una sección uretral, la que se estudia con UCG y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopía) y si hay globo vesical se maneja con cistostomía suprapúbica. Segunda parte

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical**

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Ante la presencia de una masa sólida intratesticular confirmada ecográficamente en un adulto joven con marcadores tumorales positivos, el procedimiento mandatorio inicial es la Orquiectomía Inguinal Radical. La incisión debe realizarse a nivel inguinal (por encima del ligamento inguinal) con clampeo vascular temprano del cordón espermático a nivel del anillo profundo para evitar la diseminación hematógena. La biopsia o abordaje transescrotal está formalmente contraindicada porque abre una vía linfática aberrante hacia los ganglios inguinales superficiales. Perla. Nunca puncionar un testículo con sospecha tumoral.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: B**

**Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical**

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Esta es una regla de oro oncológica fundamental: las células de seminoma puro carecen de la capacidad genética y bioquímica para sintetizar Alfafetoproteína (AFP). Por lo tanto, si un paciente con presunto seminoma presenta elevación de AFP en suero, existe obligatoriamente un componente histológico no seminomatoso no identificado en la muestra (habitualmente carcinoma embrionario o tumor del saco vitelino). Para todos los fines terapéuticos y de pronóstico, el paciente DEBE ser reclasificado y tratado con los protocolos de Tumor No Seminomatoso (los cuales son radiorresistentes y requieren quimioterapia BEP).

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

**Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical**

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Dado que el cáncer testicular afecta a hombres jóvenes en plena edad fértil y que los esquemas quimioterápicos con cisplatino (BEP) o la linfadenectomía retroperitoneal (que puede producir eyaculación retrógrada permanente por lesión de los nervios simpáticos hipogástricos) conllevan un alto riesgo de azoospermia o infertilidad transitoria o permanente, es un estándar ético y médico mandatorio ofrecer y gestionar la **criopreservación de semen** previo al inicio de cualquier terapia oncológica adyuvante.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical**

1.12.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La **criptorquidia** (falla en el descenso testicular hacia el escroto) es el factor de riesgo congénito más fuertemente asociado al cáncer testicular, multiplicando el riesgo entre 4 y 10 veces en comparación con la población general. Si bien la orquidopexia quirúrgica temprana (antes del primer año de vida) mejora el potencial de fertilidad y disminuye en parte el riesgo, no lo iguala al de la población normal, y además confiere un riesgo aumentado para el testículo contralateral normalmente descendido.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía**

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Todo tumor renal sólido (con pocas excepciones) se presume un cáncer renal. Si son menores a 7 cm (antes era 4), se tratan con nefrectomía parcial (más aún en monorrenos o insuficientes renales). Si son más de 7 cm se tratan con nefrectomía radical. Si tienen metástasis ganglionares, van a terapia paliativa (la inmunoterapia puede servir, pero poco y es muy cara). Si es de pelvis renal, se hace nefroureterectomía.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía**

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Ante el hallazgo ecográfico de una masa renal sólida en un paciente adulto, el estudio diagnóstico de elección estándar es la **Tomografía Computarizada de abdomen y pelvis multifásica (trifásica) con contraste endovenoso**. Este examen permite confirmar si la lesión es sólida o quística, evaluar el realce tras el contraste (criterio cardinal de carcinoma de células renales si aumenta > 15-20 UH), definir la anatomía quirúrgica vascular y descartar invasión de la vena renal o ganglios retroperitoneales. La biopsia percutánea preoperatoria no está indicada de rutina.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

4.03.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía**

Para tumores renales sólidos en estadio clínico T1a (≤ 4 cm de diámetro) localizados, la **Nefrectomía Parcial** (resección del tumor con un margen libre de parénquima sano) es el tratamiento curativo de referencia de primera elección. Ofrece tasas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global idénticas a la nefrectomía radical completa, pero preserva significativamente mayor masa nefronal funcionante, reduciendo a largo plazo el riesgo de enfermedad renal crónica, diálisis y eventos cardiovasculares adversos.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

4.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática (sin otros síntomas; si en cambio viene con síntomas de ITU, es ITU; si viene con síntomas de litiasis, es litiasis, etc.) en el adulto, en especial si es un paciente fumador. Las demás opciones tienen otros síntomas. La clínica clásica del cáncer renal es: masa, hematuria y fiebre (más ictericia en algunos casos).

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

4.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

La hematuria monosintomática del adulto sugiere un cáncer de vejiga. El antecedente de fumar, también.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

4.03.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hematuria" (4.03.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

4.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

En un paciente con alta sospecha de cáncer de vejiga por hematuria macroscópica indolora y antecedente de tabaquismo severo, la **Cistoscopía** es el estándar de oro diagnóstico indiscutido. Permite la inspección visual endoscópica directa de toda la mucosa vesical, cuello y uretra, localizar el número, tamaño y morfología de las lesiones papilares y proceder en el mismo acto quirúrgico a la Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) diagnóstica y terapéutica. La citología de orina es complementaria pero no reemplaza la cistoscopía.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

4.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

El paciente presenta un Cáncer de Vejiga No Músculo Invasivo (CVNMI) de alto riesgo estadio T1 (invasión de lámina propia pero sin penetración a la capa muscular detrusor). Tras una RTUV completa, el tratamiento adyuvante estándar de primera línea para prevenir la alta tasa de recurrencia y progresión a cáncer invasivo son las **instilaciones intravesicales con BCG (Bacilo de Calmette-Guérin)** en esquema de inducción semanal durante 6 semanas seguido de mantención por 1 a 3 años. La cistectomía radical se reserva para falla de BCG o invasión muscular (≥ T2).

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

4.03.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

**Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hematuria masiva" como urgencia clínica (4.03.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 73** **Respuesta: D** Estenosis uretral 4.03.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Parece una estenosis uretral postraumática. Dada la edad y el tacto rectal, es im- probable que sean las demás causas de UOB.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** Reflujo vésico ureteral 4.03.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Reflujo vésico ureteral" (4.03.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia** 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En la prostatitis bacteriana aguda, el **masaje prostático está formalmente contraindicado**. La compresión manual de una glándula prostática agudamente infectada y microabscedada puede provocar la diseminación bacteriana masiva a través del plexo venoso periprostático hacia la circulación sistémica, precipitando una bacteriemia fulminante y shock séptico. Además, el procedimiento es extraordinariamente doloroso. El diagnóstico se confirma con la clínica típica y urocultivo simple de orina emitida. Perla. El test de Stamey con masaje se reserva únicamente para la prostatitis crónica en frío.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: C**

**Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia** 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A diferencia de las cistitis o pielonefritis no complicadas que requieren cursos antibióticos de 3 a 7 días, la **prostatitis bacteriana aguda requiere esquemas prolongados de 3 a 4 semanas (21 a 28 días)**. Esto se debe a que la barrera hemato-prostática y el estroma fibromuscular dificultan la penetración y concentración tisular del fármaco una vez que cede la inflamación aguda inicial. Los tratamientos breves conllevan una altísima tasa de recidiva, persistencia de microfocos bacterianos y evolución tórpida hacia una prostatitis bacteriana crónica de muy difícil erradicación.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A**

**Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia** 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

**Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia** 1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

**PREGUNTA 79** **Respuesta: A**

**Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia**

1.11.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia, la conducta médica prioritaria es: La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La lesión reúne todos los criterios ecográficos universales de un **Quiste Renal Simple Benigno (Categoría Bosniak I)**: anecogénico, paredes no visibles, refuerzo posterior y sin ecos internos ni tabiques. Los quistes simples son variantes anatómicas extremadamente prevalentes en adultos mayores de 50 años que carecen de potencial de malignización. No requieren confirmación tomográfica, punción aspirativa ni controles ecográficos seriados. La conducta médica correcta es tranquilizar a la paciente y darle el alta.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Entre un 8 y un 10% de los pacientes con Poliquistosis Renal Autosómica Dominante presentan aneurismas saculares congénitos de las arterias cerebrales del polígono de Willis (aneurismas de Berry), porcentaje que asciende al 20% si hay antecedentes familiares de aneurisma o ACV. La rotura de uno de estos aneurismas desencadena una **Hemorragia Subaracnoidea (HSA)** clásica, manifestada por cefalea en trueno súbita de máxima intensidad, signos meníngeos y riesgo vital inminente, requiriendo TAC de encéfalo sin contraste urgente.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante, la conducta médica prioritaria es: El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

**Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante**

4.03.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Lesiones quísticas del riñón" (4.03.1.018), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El hallazgo de hematíes dismórficos en más del 80%, acantocitos (células G1) > 5% y la presencia patognomónica de **cilindros hemáticos** asociados a proteinuria y síndrome nefrítico (hipertensión y edema postinfeccioso) confirman de forma inequívoca el **origen glomerular** del sangrado. En este escenario están contraindicados los estudios urológicos invasivos (cistoscopía) y la conducta correcta es la derivación a Nefrología para estudio etiológico y eventual biopsia renal.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

**Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presencia de **coágulos macroscópicos en la orina descarta de manera prácticamente categórica el origen glomerular**. En el túbulo renal existen altas concentraciones de activador tisular del plasminógeno y uroquinasa que degradan la fibrina, impidiendo la formación de coágulos cuando el sangrado se origina en el glomérulo o túbulos proximales. Por lo tanto, cualquier paciente que elimine coágulos sanguíneos presenta un sangrado de origen extraglomerular o urológico (pelvis renal, uréter, vejiga, próstata o uretra).

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

**Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

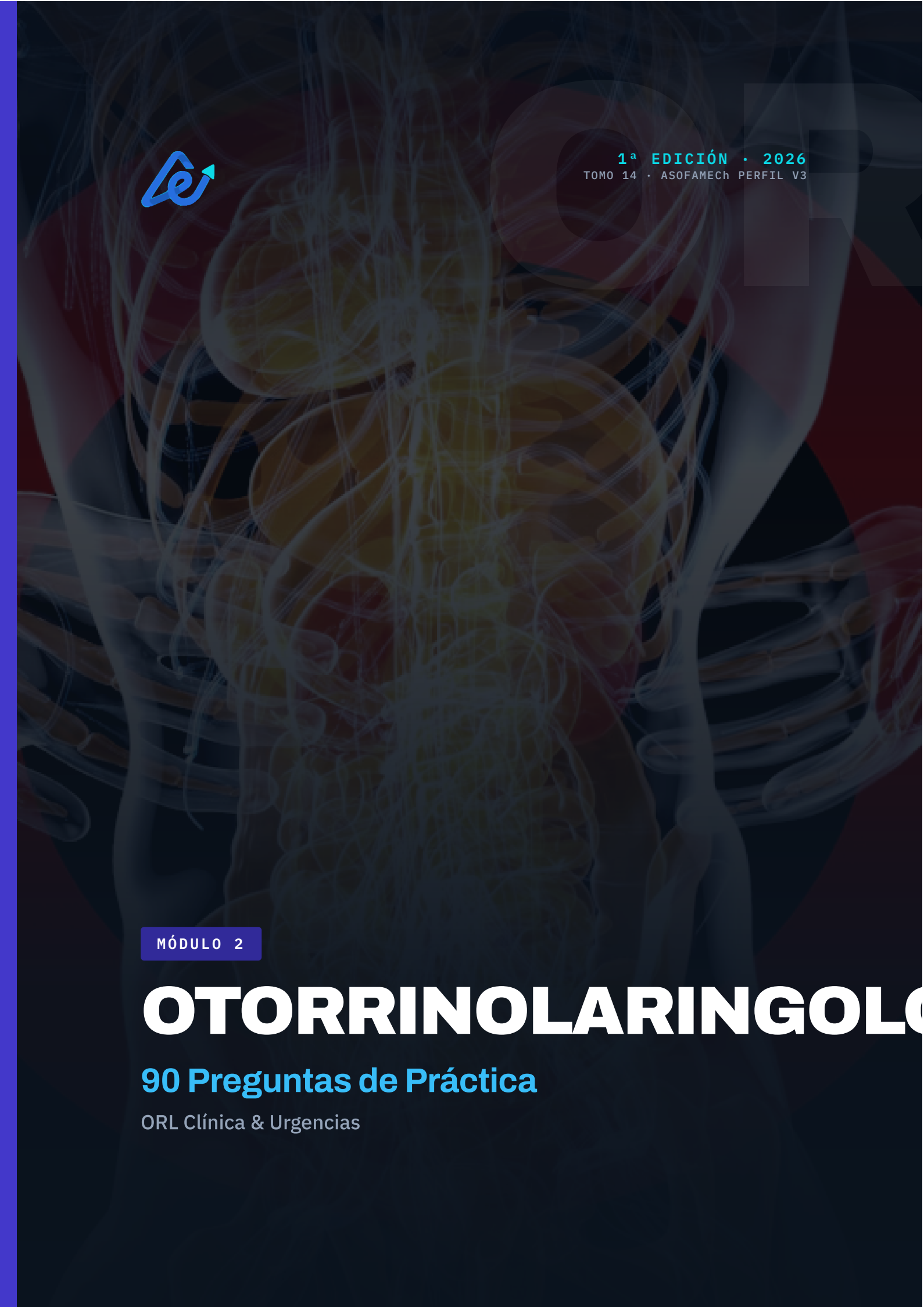
**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas**

1.07.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas, la conducta médica prioritaria es: La hematuria se define como ≥ 3 glóbulos rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---



1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 14 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 2

# OTORRINOLARINGOL

## 90 Preguntas de Práctica

ORL Clínica & Urgencias

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Otorrinolaringología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 14 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO** | | | | | |
| 4.02.4.016 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 14 · 14.1 (Pág. 5) |
| 4.02.4.017 | Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16, Q17 | Tomo 14 · 14.3 (Pág. 11) |
| 6.01.1.004 | Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q13, Q14 | Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9) |
| 6.03.1.001 | Alergia nasosinusal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.007 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.008 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.018 | Odinofagias crónicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.019 | Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.020 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q10 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.021 | Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q15 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.022 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.001 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q12 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.013 | Hematoma nasoseptal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO** | | | | | |
| 4.02.4.004 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 14 · 14.5 (Pág. 20) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03.1.009 | Disfonías agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.014 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.026 | Rinorreas agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q20 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.027 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.028 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.029 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.032 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.033 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.006 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.014 | Otohematoma | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.017 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.018 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES** | | | | | |
| 4.02.4.012 | Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q52, Q53 | Tomo 14 · 14.9 (Pág. 35) |
| 4.02.4.014 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q42, Q43, Q44, Q45 | Tomo 14 · 14.11 (Pág. 39) |
| 4.02.4.018 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q49 | Tomo 14 · 14.12 (Pág. 43) |
| 6.03.1.010 | Disfonías crónicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.011 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03.1.012 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q47 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.016 | Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q54 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.024 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.030 | Sinusopatías crónicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.011 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.012 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.015 | Otorragia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR** | | | | | |
| 4.01.2.001 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.002 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q58, Q59, Q60, Q61 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.01.2.004 | Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q71 | Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56) |
| 6.03.1.002 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q62 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.003 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.013 | Estridor laríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.025 | Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.031 | Tinitus | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.002 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.003 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.004 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q70 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.016 | Perforación timpánica traumática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q57 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| **BLOQUE 5: CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL** | | | | | |
| 4.02.5.001 | Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q81, Q82 | Tomo 14 · 14.19 (Pág. 69) |
| 4.02.6.001 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q84, Q85 | Tomo 14 · 14.20 (Pág. 71) |
| 4.02.7.002 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76 | Tomo 14 · 14.18 (Pág. 67) |
| 6.03.1.004 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q86 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.005 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87, Q88 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.006 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q89 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.015 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.017 | Odinofagias agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.023 | Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.005 | Atresia coanal congénita | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q74 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.007 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.008 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q78 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.009 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.010 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Otorrinolaringología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

**TOMO 14 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO**

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.001 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9) |
| 4.01.2.002 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q58, Q59, Q60, Q61 | Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20) |
| 4.01.2.004 | Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q71 | Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56) |
| 4.02.4.004 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q22, Q23, Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 14 · 14.5 (Pág. 20) |
| 4.02.4.012 | Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q52, Q53 | Tomo 14 · 14.9 (Pág. 35) |
| 4.02.4.014 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q42, Q43, Q44, Q45 | Tomo 14 · 14.11 (Pág. 39) |
| 4.02.4.016 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 14 · 14.1 (Pág. 5) |
| 4.02.4.017 | Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q16, Q17 | Tomo 14 · 14.3 (Pág. 11) |
| 4.02.4.018 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q49 | Tomo 14 · 14.12 (Pág. 43) |
| 4.02.5.001 | Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q81, Q82 | Tomo 14 · 14.19 (Pág. 69) |
| 4.02.6.001 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q84, Q85 | Tomo 14 · 14.20 (Pág. 71) |
| 4.02.7.002 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76 | Tomo 14 · 14.18 (Pág. 67) |
| 6.01.1.004 | Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Especialista** | GES | Q13, Q14 | Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9) |
| 6.03.1.001 | Alergia nasosinusal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.002 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q62 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.003 | Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03.1.004 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q86 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.005 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87, Q88 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.006 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q89 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.007 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.008 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.009 | Disfonías agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.010 | Disfonías crónicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.011 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.012 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q47 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.013 | Estridor laríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.014 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.015 | Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.016 | Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q54 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.017 | Odinofagias agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.018 | Odinofagias crónicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.019 | Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.020 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q10 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.021 | Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q15 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colesteatomatosa | **Derivar** | | | |
| 6.03.1.022 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.023 | Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.024 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.025 | Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.026 | Rinorreas agudas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q20 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.027 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.028 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.029 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.030 | Sinusopatías crónicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.031 | Tinitus | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.032 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.1.033 | Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.001 | Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q12 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.002 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.003 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q69 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.004 | Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q70 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.005 | Atresia coanal congénita | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q74 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| 6.03.2.006 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.007 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.008 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q78 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.009 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.010 | Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.011 | Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.012 | Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.013 | Hematoma nasoseptal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.014 | Otohematoma | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.015 | Otorragia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.016 | Perforación timpánica traumática | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.017 | Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |
| 6.03.2.018 | Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

PREGUNTA 1 6.03.1.001

**1. Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Antihistamínicos orales
B) Antibióticos orales
C) Corticoides tópicos
D) Derivar a cirugía de adenoides
E) Oximetazolina tópica

PREGUNTA 2 6.03.1.018

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Odinofagias crónicas · 6.03.1.018] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Odinofagias crónicas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 6.03.2.013

**3. Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Drenaje por punción con aguja fina
B) Drenaje quirúrgico con bisturí
C) Taponamiento anterior
D) Administrar analgésicos
E) Reducción en pabellón

PREGUNTA 4 4.02.4.016

**4. Un lactante de 14 meses es diagnosticado de otitis media aguda derecha y se le prescribe amoxicilina en dosis de 85 mg/kg/día. A las 72 horas de tratamiento, la madre vuelve a consultar porque el niño persiste febril (38.8°C), muy irritable y con dolor en el oído. La otoscopía de control muestra persistencia del abombamiento y eritema timpánico. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada en este momento?**

A) Aumentar la dosis de amoxicilina a 120 mg/kg/día y controlar en 48 horas.
B) Cambiar el tratamiento antimicrobiano a amoxicilina con ácido clavulánico oral.
C) Suspender la amoxicilina e iniciar gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona.
D) Derivar de urgencia para miringotomía y timpanocentesis inmediata.
E) Mantener la amoxicilina por 48 horas adicionales ya que el efecto bactericida puede tardar hasta 5 días.

PREGUNTA 5 4.02.4.016

**5. Un niño de 4 años presenta cuadro de 2 días de rinorrea serosa y fiebre leve. Su madre nota que no responde adecuadamente cuando se le habla despacio. Al examen físico, el niño no tiene dolor ótico. La otoscopía revela tímpanos íntegros, de aspecto translúcido pero discretamente opacos y de color amarillento-ámbar, con presencia de nivel hidroaéreo y burbujas detrás de la membrana, sin eritema ni abombamiento. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?**

A) Otitis media aguda; iniciar amoxicilina a 90 mg/kg/día por 10 días.
B) Otitis media con efusión; conducta expectante y control en 3 meses.
C) Otitis media crónica colesteatomatosa; solicitar TAC de peñasco urgente.
D) Otitis externa difusa; indicar gotas óticas de neomicina y polimixina B.
E) Disfunción tubárica aguda; iniciar corticoides orales y antihistamínicos por 14 días.

PREGUNTA 6 4.02.4.016

**6. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el agente etiológico aislado con mayor frecuencia en la otitis media aguda bacteriana no complicada en Chile?**

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Streptococcus pneumoniae
C) Staphylococcus aureus
D) Klebsiella pneumoniae
E) Streptococcus pyogenes

PREGUNTA 7 4.02.4.016

**7. Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo satisfactoriamente a la amoxicilina en cada oportunidad. La madre pregunta cuál es la definición médica de su condición y el paso a seguir. ¿Cuál es la respuesta correcta?**

A) Corresponde a una otitis media crónica supurada y debe iniciar profilaxis antibiótica diaria con cotrimoxazol.
B) Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al especialista otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.
C) No cumple criterios de recurrencia porque se requieren al menos 5 episodios en 6 meses.
D) Se trata de una falla inmunológica primaria y requiere inmunoglobulinas endovenosas mensuales.
E) Debe recibir amoxicilina en dosis profiláctica continua durante toda la temporada de invierno.

PREGUNTA 8 6.03.1.007

**8. Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último embarazo. Su otoscopía es normal y el examen neurológico no muestra alteraciones vestibulares ni cerebelosas. Se realiza test de diapasones, que muestra prueba de Rinne negativo bilateral y prueba de Weber que no lateraliza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipoacusia genética neurosensorial
B) Ototoxicidad
C) Otoesclerosis
D) Hipoacusia hormonal
E) Otitis media con efusión

PREGUNTA 9 6.03.1.008

**9. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales · 6.03.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 6.03.1.020

**10. Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:**

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina/ Ac. clavulánico
C) Ciprofloxacino tópico
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

PREGUNTA 11 6.03.1.022

**11. Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación 8mpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al examen Fsico, la otoscopía muestra la perforación 8mpánica conocida, con presencia de secreción amarillenta en relación al `mpano y al conducto audi8vo externo. ¿Qué an8bió8co es de elección para el tratamiento inicial de este paciente?**

A) Neomicina tópica
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina oral
D) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
E) Cejriaxona endovenosa

PREGUNTA 12 6.03.2.001

**12. [URGENCIA: Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica · 6.03.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 13 6.01.1.004

**13. Un escolar de 6 años es evaluado en el policlínico por sospecha de déficit atencional, ya que en el colegio la profesora nota que no obedece las órdenes y pide con frecuencia que le repitan las frases. No ha tenido otalgia ni fiebre. A la otoscopía se aprecian membranas timpánicas íntegras, ligeramente retraídas, de color amarillento y con visualización de nivel hidroaéreo y burbujas bilaterales. La timpanometría arroja curvas tipo B bilaterales con hipoacusia de conducción de 25 dB. El cuadro se ha documentado por 4 meses consecutivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Corticoides sistémicos orales en pulsos por 10 días.
B) Amoxicilina con ácido clavulánico por 21 días consecutivos.
C) Inserción bilateral de tubos de ventilación timpánica (colleras).
D) Realización inmediata de mastoidectomía bilateral abierta.
E) Tratamiento prolongado con antihistamínicos orales y descongestionantes nasales.

PREGUNTA 14 6.01.1.004

**14. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen otoscópico orienta con mayor especificidad a una otitis media crónica colesteatomatosa por sobre una otitis media crónica simple?**

A) Perforación central puntiforme en el cuadrante anteroinferior de la pars tensa.
B) Presencia de escamas blanquecinas nacaradas en una perforación marginal en la pars flácida.
C) Membrana timpánica abombada y eritematosa con pulsación visible.
D) Otorrea mucosa transparente no fétida a través de una perforación amplia que respeta el annulus.
E) Membrana timpánica íntegra con burbujas de aire retro timpánicas.

PREGUNTA 15 6.03.1.021

**15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Otitis media con efusión · 6.03.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Otitis media con efusión. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 4.02.4.017

**16. Un joven de 22 años, aficionado al surf, consulta por dolor intenso en el oído derecho de 48 horas de evolución, acompañado de sensación de oído tapado y prurito. No ha tenido fiebre ni síntomas respiratorios. Al examen físico, la movilización del pabellón auricular y la palpación del trago provocan un dolor muy intenso. La otoscopía revela edema circunferencial eritematoso del conducto auditivo externo con detritos blanquecinos abundantes, sin permitir ver con claridad el tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días.
B) Aseo ótico y gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide tópico por 7 a 10 días, asociado a analgesia oral.
C) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 14 días y reposo laboral.
D) Lavado de oídos con abundante agua tibia a presión para despejar el conducto.
E) Hospitalización inmediata para administración de ceftriaxona endovenosa.

PREGUNTA 17 4.02.4.017

**17. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente tanto de la otitis externa difusa aguda como de la otitis externa maligna necrotizante?**

A) Staphylococcus epidermidis
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Moraxella catarrhalis

PREGUNTA 18 6.03.1.019

**18. Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen Fsico, presenta dolor intenso a la compresión del trago y, en la otoscopía, se observa edema del conducto audi8vo y presencia de secreción amarillenta. El `mpano se observa sin perforación, de aspecto grisáceo. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Forunculosis del conducto audi2vo externo
B) O22s externa
C) O22s media aguda
D) Colesteatoma
E) Candidiasis del oído

## BLOQUE 2 AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

PREGUNTA 19 6.03.1.009

**19. Una paciente de 27 años sufre atoro con un pedazo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persis8do con disfonía y carraspera. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar endoscopía diges2va alta
B) Solicitar radiogra:as de cuello
C) Solicitar TAC de cuello
D) Solicitar nasofibrolaringoscopía
E) Solicitar videodeglución

PREGUNTA 20 6.03.1.026

**20.** **Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:**

A) Amoxicilina oral
B) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
C) Corticoide tópico
D) Descongestionantes tópicos
E) Antihistamínicos orales

PREGUNTA 21 6.03.2.014

**21.** **[URGENCIA: Otohematoma · 6.03.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Otohematoma. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 22 4.02.4.004

**22.** **Un paciente consulta por hipoacusia en el oído izquierdo. Al examen con diapasón de 512 Hz, la prueba de Weber lateraliza hacia el oído derecho y la prueba de Rinne es positiva bilateralmente (VA > VO en ambos oídos). ¿A cuál de los siguientes diagnósticos orienta este patrón semiológico?**

A) Hipoacusia de conducción del oído izquierdo.
B) Hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo.
C) Hipoacusia de conducción del oído derecho.
D) Audición perfectamente normal en ambos oídos.
E) Tapón de cerumen ocluyente en el conducto auditivo izquierdo.

PREGUNTA 23 4.02.4.004

**23.** **¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la presencia de líquido seroso intratimpánico en la otitis media con efusión (OME)?**

A) Curva A (pico centrado a 0 daPa con amplitud normal).
B) Curva As (amplitud disminuida con presión normal).
C) Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance).
D) Curva C (pico desplazado a presiones negativas menores a -100 daPa).
E) Curva Ad (amplitud muy aumentada por discontinuidad de cadena).

PREGUNTA 24 6.03.1.032

**24.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno de deglución · 6.03.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno de deglución. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 6.03.1.033

**25.** **Un niño de 4 años presenta escaso vocabulario para su edad y confunde muchas palabras. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el estudio de este paciente?**

A) Evaluación fonoaudiológica
B) Potenciales evocados auditivos
C) Emisiones otoacústicas
D) Audiometría
E) Control en 6 meses

PREGUNTA 26 4.02.4.004

**26.** **Un hombre de 52 años consulta por pérdida súbita de la audición del oído derecho que notó al despertar hoy en la mañana, asociada a tinnitus agudo. No refiere dolor, fiebre ni secreción. A la otoscopía, ambos conductos auditivos externos están limpios y las membranas timpánicas son de aspecto normal. La prueba de Weber lateraliza al oído izquierdo y el Rinne es positivo en ambos oídos. ¿Cuál es la conducta inicial de elección que debe instaurarse de forma inmediata?**

A) Realizar lavado de oído bilateral con agua tibia para retirar eventual tapón de cera profundo.
B) Indicar descongestionantes orales y citar a control ambulatorio en 3 semanas.
C) Iniciar de inmediato prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día y solicitar audiometría urgente.
D) Prescribir gotas óticas de ciprofloxacino con hidrocortisona cada 8 horas por 7 días.
E) Tranquilizar al paciente indicando que se trata de un cuadro viral autolimitado que no requiere fármacos.

PREGUNTA 27 4.02.4.004

**27. Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que 'oye pero no entiende'. No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?**

A) Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES.
B) Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales.
C) Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida.
D) Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización.
E) Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1.

PREGUNTA 28 4.02.4.004

**28. Un calderero industrial de 45 años, con 20 años de labor en maestranza sin uso constante de protectores auditivos, se realiza una audiometría ocupacional periódica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos audiométricos es característico y patognomónico del trauma acústico crónico por ruido laboral?**

A) Pérdida auditiva de conducción con curva timpanométrica tipo B.
B) Caída del umbral auditivo neurosensorial en las frecuencias graves (250 a 500 Hz).
C) Muesca o escotoma neurosensorial bilateral selectivo en la frecuencia de 4000 Hz.
D) Brecha óseo-aérea de 30 dB en todas las frecuencias con vía ósea normal.
E) Caída plana sensorioneural de 90 dB en todas las frecuencias del oído derecho únicamente.

PREGUNTA 29 4.02.4.004

**29. En un paciente con hipoacusia sensorioneural súbita idiopática de 48 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes estudios de neuroimagen es el de elección para descartar de forma definitiva una patología retrococlear como el neurinoma del acústico (schwannoma vestibular)?**

A) Radiografía de cráneo en proyección transorbitaria.
B) Tomografía computarizada (TAC) de cerebro sin contraste.
C) Resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro y ángulo pontocerebeloso con gadolinio.
D) Angiografía cerebral por sustracción digital de arteria basilar.
E) Ecografía Doppler de arterias carótidas y vertebrales.

PREGUNTA 30 6.03.1.014

**30. Lactante que llega sin test de audición a primer control:**

A) Emisiones otoacústicas
B) Impedanciometría
C) Evaluación por fono
D) Audiometría
E) Reflejo cocleopalpebral

PREGUNTA 31 6.03.2.006

**31. Una paciente de 33 años, consulta por otalgia y sensación de oído tapado, mayor a derecha. Refiere que el día anterior estuvo nadando, sumergiéndose a 1,5 metros de profundidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Otitis media aguda
B) Otitis media con efusión
C) Perforación timpánica
D) Otitis externa
E) Barotrauma

PREGUNTA 32 6.03.2.018

**32. Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopía no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?**

A) Impedanciometría
B) TAC de oído
C) TAC de cerebro
D) Prueba calórica
E) Audiometría

PREGUNTA 33 6.03.1.027

**33. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndrome de apnea del sueño · 6.03.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndrome de apnea del sueño. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 6.03.1.028

**34. Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuent**

E) Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:
A) Rinofibroangioma bilateral
B) Rinitis alérgica
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Hipertrofia de adenoides

PREGUNTA 35 6.03.1.029

**35. Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas duran horas. Audiometría disponible en una semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Ménière
B) Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
C) Neuritis vestibular
D) ACV de fosa posterior
E) Schwannoma vestibular

PREGUNTA 36 6.03.2.017

**36. Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:**

A) Parálisis cocleovestibular
B) Vértigo postural
C) Hídrops endolinfático
D) Neuronitis vestibular
E) Neurinoma del acústico

## BLOQUE 3 RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

PREGUNTA 37 6.03.1.010

**37. Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?**

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 38 6.03.1.030

**38. Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Realizar cirugía endoscópica nasal
C) Solicitar rinomanometría
D) Indicar tratamiento antibiótico
E) Iniciar antihistamínicos orales

PREGUNTA 39 6.03.2.015

**39. [URGENCIA: Otorragia · 6.03.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Otorragia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 40 4.02.4.012

**40. Un hombre de 32 años consulta por cuadro de congestión nasal, rinorrea amarillenta espesa y cefalea frontal opresiva de 12 días de evolución sin mejoría. Refiere haber utilizado paracetamol e inhalaciones de vapor sin experimentar alivio. No presenta fiebre actual ni alteraciones visuales. Al examen físico se aprecia descarga mucopurulenta en el meato medio a la rinoscopía anterior y sensibilidad a la palpación sobre ambos senos maxilares. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta de elección?**

A) Rinitis alérgica estacional; iniciar antihistamínicos orales y derivar a inmunoterapia.
B) Rinosinusitis viral no complicada; mantener analgesia sintomática exclusiva por 10 días más.
C) Rinosinusitis bacteriana aguda; iniciar tratamiento con amoxicilina oral por 7 a 10 días.
D) Sinusitis fúngica invasora; hospitalizar para debridamiento quirúrgico inmediato.
E) Poliposis nasal sobreinfectada; solicitar radiografía simple de cráneo en proyección de Waters.

PREGUNTA 41 4.02.4.012

**41. Un escolar de 8 años con rinosinusitis aguda presenta aumento de volumen y eritema palpebral izquierdo. Al examen físico se comprueba limitación en la aducción y abducción del ojo izquierdo, diplopía y proptosis del globo ocular. La agudeza visual se mantiene conservada. ¿A cuál de los siguientes estadios de la clasificación de Chandler corresponde este cuadro clínico?**

A) Estadio I: Celulitis preseptal o periorbitaria.
B) Estadio II: Celulitis orbitaria postseptal.
C) Estadio III: Absceso subperióstico.
D) Estadio IV: Absceso orbitario con pérdida visual.
E) Estadio V: Trombosis séptica del seno cavernoso.

PREGUNTA 42 4.02.4.014

**42. Un niño de 9 años consulta en el servicio de urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente estable. Se realiza compresión bimanual de las alas nasales durante 15 minutos continuos con cabeza hacia adelante, pero al soltar persiste sangrado leve. Al colocar un algodón con vasoconstrictor y retirar bajo buena luz con espéculo nasal, se visualiza claramente un vaso sangrante superficial en la porción anteroinferior del tabique nasal derecho. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a continuación?**

A) Realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley de urgencia.
B) Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.
C) Indicar ácido tranexámico endovenoso y hospitalizar para observación.
D) Cauterización bilateral simultánea de ambas caras del tabique nasal.
E) Indicar al paciente mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante las próximas 4 horas.

PREGUNTA 43 4.02.4.014

**43. Una paciente de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no ha cedido tras taponamiento anterior bilateral con Merocel, evidenciándose sangrado activo continuo y abundante por la faringe posterior. Se decide realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley. Respecto al manejo integral de esta paciente, ¿cuál de las siguientes medidas es una indicación OBLIGATORIA?**

A) Alta inmediata a domicilio con indicación de retirar la sonda Foley a las 12 horas.
B) Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.
C) Insuflar el balón de la sonda Foley con 25 mL de aire para asegurar hemostasia máxima.
D) Suspensión absoluta de toda hidratación parenteral y mantener presión arterial sistólica sobre 180 mmHg.
E) Realizar cauterización a ciegas con nitrato de plata de la pared posterior de la orofaringe.

PREGUNTA 44 4.02.4.014

**44. ¿Cuál es la anastomosis arterial responsable de la gran mayoría de las epistaxis anteriores en niños y adultos jóvenes, localizada en la región anteroinferior del tabique nasal?**

A) Plexo venoso pampiniforme.
B) Plexo de Kiesselbach (Área de Little).
C) Plexo venoso de Woodruff.
D) Arteria carótida interna terminal.
E) Arteria meníngea media.

PREGUNTA 45 4.02.4.014

**45. ¿Por qué motivo está formalmente contraindicado realizar cauterización con nitrato de plata en ambas caras del tabique nasal de forma simultánea en una misma sesión?**

A) Porque induce una crisis hipertensiva severa mediada por barorreceptores.
B) Por el riesgo de provocar isquemia, necrosis avascular y perforación septal permanente.
C) Porque aumenta el riesgo de desarrollar poliposis nasal alérgica difusa.
D) Porque desencadena parálisis del nervio olfatorio con anosmia irreversible.
E) Porque genera una sobreinfección inmediata por Pseudomonas aeruginosa.

PREGUNTA 46 6.03.1.011

**46. [ATENCIÓN PRIMARIA: Epistaxis a repetición · 6.03.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epistaxis a repetición. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 47 6.03.1.012

**47. [ATENCIÓN PRIMARIA: Epistaxis leve · 6.03.1.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Epistaxis leve. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 48 6.03.2.011

**48.** **[URGENCIA: Epistaxis masiva · 6.03.2.011] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Epistaxis masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 4.02.4.018

**49.** **Un adolescente de 15 años sufre un pelotazo en la cara durante un partido de básquetbol, presentando deformidad nasal y epistaxis que cede espontáneamente. Al ser examinado en el policlínico de choque 6 horas más tarde, el médico realiza una rinoscopía anterior y constata un abombamiento violáceo, blando y bilateral en el tabique nasal que obstruye ambas fosas nasales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata que debe adoptarse?**

A) Hipertrofia compensatoria de cornetes; indicar descongestionantes tópicos por 7 días.

B) Hematoma septal; realizar incisión, drenaje quirúrgico inmediato y taponamiento nasal bilateral compresivo.

C) Fractura nasal simple no desplazada; solicitar radiografía de huesos propios y citar a control en 10 días.

D) Poliposis nasal postraumática aguda; iniciar prednisona oral en dosis altas.

E) Desviación septal cartilaginosa fija; programar septoplastia electiva en 6 meses.

PREGUNTA 50 6.03.1.024

**50.** **Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar fluticasona tópica c/12 horas

B) Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días

C) Solicitar TAC de cavidades paranasales

D) Realizar cirugía endoscópica nasal

E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

PREGUNTA 51 6.03.2.012

**51.** **[URGENCIA: Fractura nasal reciente · 6.03.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Fractura nasal reciente. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 52 4.02.4.012

**52.** **Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos que se presentan durante 5 a 6 días a la semana desde hace 2 meses coincidiendo con la primavera. Relata que se despierta en la noche con la nariz totalmente obstruida y que esto afecta su concentración para estudiar. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores hipertróficos y pálidos. De acuerdo con las guías clínicas internacionales (ARIA), ¿cuál es la clasificación de su enfermedad y el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A) Rinitis alérgica intermitente leve; clorfenamina oral 4 mg cada 8 horas.

B) Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona).

C) Rinitis vasomotora pura; bromuro de ipratropio nasal según necesidad.

D) Rinosinusitis crónica poliposa; amoxicilina oral con ácido clavulánico por 21 días.

E) Rinitis alérgica persistente leve; oximetazolina nasal tópica cada 12 horas por 1 mes.

PREGUNTA 53 4.02.4.012

**53.** **¿Cuál es la causa subyacente y la conducta terapéutica correcta ante un paciente que presenta congestión nasal severa y empeoramiento clínico progresivo tras haber utilizado spray nasal de oximetazolina de venta libre de manera continua durante 4 semanas?**

A) Sobreinfección bacteriana por Pseudomonas; indicar ciprofloxacino oral.

B) Rinitis medicamentosa por rebote vasomotor; suspender la oximetazolina e iniciar corticoides intranasales.

C) Poliposis nasal inducida por descongestionantes; derivar a cirugía endoscópica inmediata.

D) Desensibilización alérgica; aumentar la frecuencia de aplicación de oximetazolina a cada 4 horas.

E) Perforación del tabique nasal por toxicidad; realizar cauterización química urgente.

PREGUNTA 54 6.03.1.016

**54. [ATENCIÓN PRIMARIA: Obstrucción nasal crónica · 6.03.1.016] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Obstrucción nasal crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

## BLOQUE 4 FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

PREGUNTA 55 6.03.1.013

**55. Lactante con estridor desde nacimiento causa a. Laringomalacia**

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

PREGUNTA 56 6.03.1.031

**56. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tinitus · 6.03.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tinitus. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 57 6.03.2.016

**57. Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopía, que muestra presencia de una perforación timpática triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Lavado de oídos
B) Ciprofloxacino tópico
C) Derivar a timpanoplastía
D) Control en un mes
E) TAC de oídos

PREGUNTA 58 4.01.2.002

**58. Un escolar de 7 años es traído a la consulta por fiebre de 38.6°C y odinofagia de 2 días de evolución. No tiene tos ni mucosidad nasal. Al examen físico destaca faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño con exudado pultáceo y adenopatías cervicales anteriores bilaterales muy sensibles a la palpación. Según los criterios de Centor modificados por McIsaac, ¿cuántos puntos tiene y cuál es la conducta de elección?**

A) 2 puntos; manejo puramente sintomático con paracetamol oral.
B) 3 puntos; solicitar hemograma con frotis y radiografía de tórax.
C) 5 puntos; iniciar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina IM o amoxicilina oral por 10 días.
D) 4 puntos; iniciar ciprofloxacino oral por 5 días para evitar nefropatía.
E) 1 punto; indicar gárgaras con sal y citar a control en 7 días si persiste con fiebre.

PREGUNTA 59 4.01.2.002

**59. Respecto a las complicaciones de la faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?**

A) El tratamiento antibiótico precoz previene eficazmente la glomerulonefritis aguda postestreptocócica.
B) El tratamiento antibiótico con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días previene la fiebre reumática aguda.
C) La penicilina benzatina no tiene efecto en la prevención de abscesos periamigdalinos supurativos.
D) La glomerulonefritis solo se presenta tras infecciones estreptocócicas de la piel y nunca tras faringitis.
E) Se ha comprobado una tasa de resistencia a penicilina superior al 20% en cepas chilenas de Streptococcus pyogenes.

PREGUNTA 60 4.01.2.002

**60. Un adolescente de 16 años consulta por odinofagia severa de 5 días de evolución, astenia marcada y fiebre. El médico sospecha amigdalitis bacteriana y le prescribe amoxicilina 875 mg cada 12 horas. Al tercer día de amoxicilina, el paciente acude a urgencias por la aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso y pruriginoso en tronco y extremidades. Al examen actual presenta amígdalas hipertróficas con exudado blanco-grisáceo, adenopatías cervicales posteriores y epitrocleares palpables y esplenomegalia a 3 cm bajo el reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Alergia anafiláctica grave a la amoxicilina mediada por IgE.
B) Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr (EBV).
C) Escarlatina estreptocócica clásica con signo de Pastia.
D) Infección aguda por citomegalovirus refractaria a penicilina.
E) Shock tóxico estreptocócico fulminante.

PREGUNTA 61 4.01.2.002

**61. En un paciente de 25 años con faringoamigdalitis estreptocócica confirmada por test rápido, con antecedente de reacción anafiláctica severa previa a la penicilina (edema de glotis y colapso circulatorio), ¿cuál de los siguientes antibióticos es la opción terapéutica de primera línea más adecuada?**

A) Amoxicilina con ácido clavulánico oral.
B) Cefadroxilo oral en dosis altas.
C) Azitromicina oral por 5 días.
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única.
E) Ampicilina oral por 10 días.

PREGUNTA 62 6.03.1.002

**62. [ATENCIÓN PRIMARIA: Amigdalitis aguda · 6.03.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Amigdalitis aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 63 6.03.1.003

**63. [ATENCIÓN PRIMARIA: Amigdalitis crónica · 6.03.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Amigdalitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 64 4.01.2.001

**64. Un joven de 19 años con diagnóstico de amigdalitis aguda en tratamiento oral con amoxicilina desde hace 3 días consulta por agravamiento del cuadro. Presenta fiebre alta, odinofagia unilateral derecha intolerable, sialorrea profusa y marcada dificultad para abrir la boca. Al hablar se expresa con voz engorrosa apagada ('en papa caliente'). A la inspección orofaríngea se aprecia protrusión del pilar amigdalino anterior derecho con desplazamiento de la úvula hacia la izquierda. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección que debe realizarse de inmediato?**

A) Aumentar la dosis de amoxicilina oral al doble y asociar ketorolaco sublingual.

B) Punción con aguja o incisión y drenaje del espacio periamigdalino derecho e inicio de antibióticos endovenosos.

C) Solicitar tomografía computarizada de tórax ambulatoria para descartar masa tímica.

D) Intubación orotraqueal de urgencia y amigdalectomía bilateral en caliente inmediata.

E) Realizar laringoscopía indirecta con espejo para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales.

PREGUNTA 65 4.01.2.001

**65. Un lactante de 2 años presenta fiebre alta de 39.2°C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija del cuello en extensión con tortícolis dolorosa y estridor inspiratorio leve. En la radiografía lateral de cuello se evidencia un marcado ensanchamiento del espacio de partes blandas prevertebrales a nivel cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la complicación más temida de no mediar tratamiento urgente?**

A) Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente.

B) Croup viral laringotraqueal; estenosis subglótica adquirida.

C) Epiglotitis aguda; fístula traqueoesofágica espontánea.

D) Absceso periamigdalino bilateral; trombosis de arteria basilar.

E) Mononucleosis infecciosa severa; rotura esplénica retardada.

PREGUNTA 66 4.01.2.001

**66. ¿Cuál es la causa del trismus (dificultad para la apertura bucal) característico que acompaña al absceso periamigdalino y al absceso parafaríngeo?**

A) Parálisis del nervio facial a nivel del canal estilomastoideo.

B) Compromiso inflamatorio y espasmo reflejo del músculo pterigoideo interno (medial).

C) Luxación traumática de la articulación temporomandibular.

D) Compresión directa del tronco del nervio trigémino en la fosa media.

E) Trombosis de la arteria carótida externa ipsilateral.

PREGUNTA 67 4.01.2.001

**67. Un paciente de 55 años con antecedentes de mala higiene dental consulta por aumento de volumen cervical anterior y submandibular bilateral de consistencia dura 'en madera', con dolor intenso. Al examen físico destaca fiebre, dificultad respiratoria, incapacidad para tragar la saliva y elevación forzada de la lengua que se encuentra empujada hacia el paladar y hacia atrás. ¿Cuál es la prioridad absoluta en el manejo médico inmediato de este paciente?**

A) Extracción inmediata en box de las piezas dentarias cariadas bajo anestesia local.

B) Asegurar y proteger la vía aérea de forma precoz (intubación guiada o traqueostomía).

C) Administración de corticoides orales en altas dosis y reposo en domicilio.

D) Solicitud de radiografía panorámica dental ambulatoria.

E) Punción evacuadora con trocar en el piso de la boca sin anestesia.

PREGUNTA 68 6.03.2.002

**68. Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abombamiento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:**

A) Absceso retrofaríngeo

B) Angina de Ludwig

C) Amigdalitis ulcero-necrótica

D) Absceso periamigdalino

E) Mononucleosis infecciosa

PREGUNTA 69 6.03.2.003

**69. [URGENCIA: Absceso profundo de cuello · 6.03.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso profundo de cuello. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 70 6.03.2.004

**70.** **[URGENCIA: Absceso retrofaríngeo · 6.03.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Absceso retrofaríngeo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 71 4.01.2.004

**71.** **Un niño de 5 años presenta ronquidos nocturnos de 6 meses de evolución y pausas respiratorias nocturnas documentadas por sus padres de hasta 15 segundos con despertares sobresaltados y sudoración profusa. En el día respira con la boca abierta y presenta retraso pondoestatural. Al examen orofaríngeo se observan amígdalas palatinas grado 4 de Brodsky que contactan en la línea media. ¿Cuál es la conducta médica de elección más indicada?**

A) Tratamiento prolongado con antibióticos orales profilácticos por 6 meses.

B) Indicación quirúrgica de adenoamigdalectomía bilateral.

C) Uso exclusivo de descongestionantes nasales tópicos nocturnos.

D) Observación expectante hasta los 12 años esperando la involución fisiológica espontánea.

E) Tratamiento con estimulantes del sistema nervioso central para la hiperactividad.

PREGUNTA 72 6.03.1.025

**72.** **Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. El diagnóstico más probable es:**

A) Cáncer nasal

B) Pólipos nasales

C) Sinusitis bacteriana crónica

D) Rinitis vasomotora

E) Rinitis alérgica

## BLOQUE 5 CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

PREGUNTA 73 6.03.1.017

**73.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Odinofagias agudas · 6.03.1.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Odinofagias agudas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 6.03.2.005

**74.** **[URGENCIA: Atresia coanal congénita · 6.03.2.005] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Atresia coanal congénita. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 4.02.7.002

**75.** **Una madre acude al servicio de urgencia con su hijo de 3 años refiriendo que el niño se introdujo en la fosa nasal izquierda una pila de botón extraída de un juguete hace aproximadamente una hora. El niño presenta llanto y sangrado nasal escaso. Al examen se confirma la presencia de la batería en la fosa nasal. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada?**

A) Realizar lavado profuso de la fosa nasal con solución salina para neutralizar el pH y expulsar la pila.

B) Extracción inmediata del cuerpo extraño con gancho romo o derivación urgente a pabellón quirúrgico, sin realizar ninguna irrigación líquida.

C) Indicar descongestionantes orales y citar al policlínico de otorrinolaringología en 48 horas.

D) Instilar gotas de vaselina líquida para facilitar que la pila deslice hacia la nasofaringe.

E) Realizar compresión digital bimanual externa sobre el dorso nasal para aplastar la batería.

PREGUNTA 76 4.02.7.002

**76.** **Un niño de 4 años es traído a la consulta médica ambulatoria porque desde hace 3 semanas presenta mucosidad purulenta amarillenta que sale exclusivamente por la fosa nasal derecha, asociada a un olor fétido muy intenso. La madre refiere que ha sido tratado previamente con amoxicilina oral por sospecha de rinosinusitis sin ninguna mejoría. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable que debe descartarse en primer lugar?**

A) Rinitis alérgica estacional unilateral.

B) Cuerpo extraño nasal desapercibido en la fosa nasal derecha.

C) Atresia de coanas bilateral congénita tardía.

D) Fibrosis quística con sobreinfección por Pseudomonas.

E) Desviación septal cartilaginosa pura sin componente inflamatorio.

PREGUNTA 77 6.03.2.007

**77.** **[URGENCIA: Cuerpo extraño en el oído · 6.03.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño en el oído. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 78 6.03.2.008

**78.** **[URGENCIA: Cuerpo extraño en el esófago · 6.03.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño en el esófago. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 79 6.03.2.009

**79.** **Un paciente de 26 años, con antecedente de daño cerebral severo, desde hace 2 días presenta sialorrea, tos áfona, estridor inspiratorio y reticencia a alimentarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumonía aspirativa

B) Epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B

C) Crisis epiléptica focal

D) Cuerpo extraño laríngeo

E) Cuerpo extraño esofágico

PREGUNTA 80 6.03.2.010

**80.** **[URGENCIA: Cuerpo extraño nasal · 6.03.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Cuerpo extraño nasal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 81 4.02.5.001

**81. Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha que aparece típicamente al comenzar a comer y cede gradualmente dos horas después. La palpación bimanual del piso de la boca revela una zona indurada milimétrica dolorosa a lo largo del trayecto del conducto salival. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el conducto excretor involucrado?**

A) Parotiditis viral urliana; conducto de Stenon.
B) Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton.
C) Adenoma pleomorfo submandibular; conducto de Rivinus.
D) Ranula sublingual simple; conducto de Bartolino.
E) Angina de Ludwig inicial; conducto tireogloso persistente.

PREGUNTA 82 4.02.5.001

**82. Una paciente de 42 años consulta por un nódulo indoloro en la región parotídea derecha que notó hace aproximadamente 1 año, de crecimiento muy lento. Al examen físico se palpa un nódulo de 2.5 cm en el polo inferior de la parótida derecha, de consistencia firme-elástica, superficie lisa, móvil, no adherido a planos profundos ni a la piel. La motilidad de la musculatura mímica facial es rigurosamente normal y simétrica en ambos lados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento quirúrgico de elección?**

A) Carcinoma mucoepidermoide de alto grado; parotidectomía radical con sección del nervio facial y radioterapia.
B) Adenoma pleomorfo; parotidectomía superficial con disección y preservación del nervio facial.
C) Quiste branquial infectado; drenaje percutáneo ambulatorio e inicio de cloxacilina.
D) Sialometaplasia necrotizante; enucleación tumoral simple con bisturí frío en el box.
E) Parotiditis bacteriana crónica; tratamiento prolongado con amoxicilina-ácido clavulánico.

PREGUNTA 83 6.03.1.023

**83. Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al examen Fsico se palpa la glándula paró8da derecha aumentada de tamaño, dolorosa a la compresión. Al interrogatorio, la madre refiere que desde los 4 años ha presentado cuatro episodios similares, que han respondido al tratamiento con analgésicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Síndrome de Sjögren
B) Paro2di2s viral recurrente
C) Li2asis del conducto de Stensen
D) Paro2di2s crónica
E) Tumor paroadeo

PREGUNTA 84 4.02.6.001

**84. Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de evolución, indolora y de consistencia pétrea de 3 cm de diámetro. Refiere además otalgia refleja izquierda ocasional con otoscopía rigurosamente normal. Respecto a la conducta diagnóstica inicial más apropiada, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el método de elección para la confirmación anatomopatológica y qué procedimiento está formalmente contraindicado?**

A) Método de elección: Biopsia incisional abierta en pabellón bajo anestesia local. Procedimiento contraindicado: PAAF bajo ecografía.
B) Método de elección: Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía. Procedimiento contraindicado: Biopsia ganglionar abierta antes de descartar tumor primario en vía aérea superior.
C) Método de elección: Drenaje por aspiración con trócar grueso pensando en quiste sebáceo. Procedimiento contraindicado: Tomografía computarizada.
D) Método de elección: Exéresis completa de la glándula tiroides de urgencia. Procedimiento contraindicado: Nasofibroscopía flexible.
E) Método de elección: Ciclo empírico de cefadroxilo oral por 21 días. Procedimiento contraindicado: Evaluación por otorrinolaringólogo.

PREGUNTA 85 4.02.6.001

**85. ¿Cuál de los siguientes síntomas constituye una bandera roja de sospecha oncológica que obliga a descartar prioritariamente un carcinoma escamoso de la base de la lengua, hipofaringe o laringe mediante nasofibroscopía?**

A) Prurito ótico bilateral con descamación del conducto auditivo externo.
B) Otalgia persistente unilateral con examen otoscópico rigurosamente normal.
C) Hipoacusia de conducción que lateraliza al oído afectado en el test de Weber.
D) Estornudos en salva y rinorrea acuosa bilateral matinal.
E) Salida de secreción mucosa bilateral no fétida con tímpanos íntegros.

PREGUNTA 86 6.03.1.004

**86. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de boca, labios y orofaringe · 6.03.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de boca, labios y orofaringe. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 87 6.03.1.005

**87.** **Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. El diagnóstico más probable es:**

**A)** Cáncer de esófago
**B)** Disfunción temporomandibular
**C)** Cáncer de hipofaringe
**D)** Faringitis crónica
**E)** Cáncer de laringe

PREGUNTA 88 6.03.1.005

**88.** **Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a aparición de una adenopatía cervical, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?**

**A)** Radiografías de cuello
**B)** Endoscopía digestiva alta
**C)** Nasofibroscopía
**D)** Ecografía de cuello
**E)** TAC de cuello

PREGUNTA 89 6.03.1.006

**89.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer nasosinusal · 6.03.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer nasosinusal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

**A)** Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
**B)** Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
**C)** Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
**D)** Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
**E)** Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 90 6.03.1.015

**90.** **Una paciente de 35 años, que cursa una infección respiratoria alta, presenta aparición de aumento de volumen cervical progresivo, de localización suprahioidea. A la palpación, se constata consistencia gomosa y se observa que asciende al solicitarle a la paciente que protruya la lengua. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

**A)** Nódulo 2roideo
**B)** Quiste dermoide
**C)** Adenopaaa cervical
**D)** Quiste del conducto 2rogloso
**E)** Linfoma

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 — Respuesta: A — Alergia nasosinusal

6.03.1.001 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una rinitis alérgica, sin obstrucción (los corticoides tópicos serían si hubiese obstrucción)

### PREGUNTA 2 — Respuesta: A — Odinofagias crónicas

6.03.1.018 · Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Odinofagias crónicas" (6.03.1.018), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 — Respuesta: B — Hematoma nasoseptal

6.03.2.013 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

El hematoma del tabique nasal se debe drenar de inmediato, mediante incisión amplia con bisturí (también el hematoma del pabellón auricular). De lo contrario evoluciona con necrosis avascular del cartílago.

### PREGUNTA 4 — Respuesta: B

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. La persistencia de fiebre y otalgia con persistencia de signos otoscópicos a las 48-72 horas de tratamiento con amoxicilina a dosis altas constituye una falla terapéutica de primera línea. El mecanismo fisiopatológico principal es la infección por cepas de Haemophilus influenzae no tipificable o Moraxella catarrhalis productoras de betalactamasas. La conducta estandarizada por MINSAL y guías internacionales es el cambio inmediato a amoxicilina-ácido clavulánico (80-90 mg/kg/día de componente amoxicilina en relación 14:1). Opción A: Incorrecta, dosis superiores de amoxicilina sola no superan la resistencia por betalactamasas. Opción C: Incorrecta, las gotas óticas no penetran a través de una membrana timpánica íntegra. Opción D: Incorrecta, la timpanocentesis se reserva para mastoiditis, sepsis o recién nacidos. Opción E: Incorrecta, la falta de respuesta a las 72h exige cambio de antibiótico.

### PREGUNTA 5 — Respuesta: B

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. La presencia de líquido o burbujas en el oído medio con membrana timpánica retraída o en posición neutra, sin signos inflamatorios agudos (sin eritema ni abombamiento) y sin sintomatología aguda (sin otalgia ni fiebre alta), define a la Otitis Media con Efusión (OME u otitis serosa). La inmensa mayoría de los casos resuelve espontáneamente en un período de 8 a 12 semanas. La conducta recomendada por guías clínicas es la observación expectante durante 3 meses. Ni los antibióticos, ni los corticoides, ni los antihistamínicos han demostrado beneficio y están desaconsejados. Si la efusión persiste pasados los 3 meses y se acompaña de hipoacusia bilateral significativa (> 20-30 dB), se indica la colocación de tubos de ventilación timpánica.

### PREGUNTA 6 — Respuesta: B

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

4.02.4.016 · Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo · GES

La opción correcta es la B. Streptococcus pneumoniae (neumococo) continúa siendo el patógeno bacteriano más frecuente y clínicamente agresivo en OMA, responsable del 35-40% de los casos confirmados por timpanocentesis, seguido de Haemophilus influenzae no tipificable (30-35%) y Moraxella catarrhalis (10-15%). Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son agentes de otitis externa o de otitis media crónica supurada, no de OMA no complicada.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

4.02.4.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

La opción correcta es la B. La OMA recurrente se define como la presencia de ≥ 3 episodios bien documentados de OMA en 6 meses, o ≥ 4 episodios en 12 meses (con al menos 1 en los últimos 6 meses). Este paciente (3 episodios en 4 meses) cumple cabalmente la definición y debe ser derivado a ORL para evaluar inserción de tubos de ventilación timpánica (colleras), lo cual previene nuevos episodios y protege la función auditiva. La quimioprofilaxis antibiótica prolongada está contraindicada por generar resistencia bacteriana.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: C**

6.03.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

Otoesclerosis: La prueba de Rinne es positiva en hipoacusias sensorioneurales y negativa en hipoacusias de conducción, como en este caso. La prueba de Weber lateraliza al lado afectado en la hipoacusia de conducción y al lado sano en la sensorioneural; pero si la hipoacusia es bilateral y simétrica, no lateraliza. La otoesclerosis y la otitis media con efusión son hipoacusias de conducción, pero el curso crónico por 10 años y el empeoramiento durante el embarazo son característicos de la otoesclerosis. Esta última es la causa más común de hipoacusia de conducción con tímpano normal, a diferencia de la otitis media crónica que presenta alteraciones timpánicas. Las hipoacusias sensorioneurales, en cambio, tienen tímpano sano en la otoscopía.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

6.03.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales" (6.03.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

6.03.1.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 128). Evalúa el manejo clínico de Otitis media aguda según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

6.03.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

Tiene una oGGs media crónica simple, cuyo tratamiento de primera línea es tópico, con ciprofloxacino. La neomicina tópica Gene riesgo de ototoxicidad directa, por ser un aminoglicósido. Los antibióticos sistémicos se usan en los casos complicados (ej. mastoidiGs, laberintiGs). La cirugía está indicada en los casos refractarios y en caso de que haya un colesteatoma asociado.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

6.03.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica" como urgencia clínica (6.03.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: C**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa**

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Otitis Media con Efusión (OME) crónica persistente por más de 3 meses, acompañada de hipoacusia conductiva bilateral documentada que está interfiriendo en su rendimiento escolar y comunicación. Cuando la OME persiste más allá del período de observación de 3 meses con impacto auditivo (> 20-25 dB), la indicación formal y de elección es la miringotomía con colocación de tubos de ventilación timpánica (colleras), la cual restablece la ventilación de la caja timpánica y normaliza los umbrales auditivos de inmediato. Las opciones A, B y E carecen de efectividad demostrada en guías clínicas y exponen a efectos adversos innecesarios. La opción D es un procedimiento quirúrgico mayor para colesteatoma o mastoiditis, no para OME.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa**

La opción correcta es la B. Las características patognomónicas del colesteatoma en la otoscopía son la perforación marginal (que compromete el reborde óseo o annulus), habitualmente localizada en la pars flácida (ático) o cuadrante posterosuperior, a través de la cual protruyen detritos blanquecinos de queratina (escamas nacaradas) y pólipos inflamatorios con secreción purulenta de olor fétido. En contraste, la OMC simple presenta perforación central en la pars tensa respetando el annulus con otorrea mucosa no fétida (opciones A y D). La opción C describe una OMA supurada hiperaguda y la opción E describe una OME serosa.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

6.03.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Otitis media con efusión" (6.03.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: B**

4.02.4.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos**

La opción correcta es la B. El caso corresponde a una clásica Otitis Externa Difusa Aguda (oído de nadador), producida habitualmente por Pseudomonas aeruginosa y favorecida por la exposición al agua. El signo del trago intensamente positivo es el sello clínico. En ausencia de signos de diseminación periauricular o inmunosupresión, el tratamiento de elección es estrictamente local: aspiración o aseo suave de los detritos del CAE y aplicación de gotas óticas que contengan fluoroquinolonas (Ciprofloxacino) asociadas o no a corticoides (Dexametasona) para reducir el edema, junto a analgesia oral con AINEs y protección estricta del agua. Los antibióticos orales (opciones A y C) no son necesarios y tienen menor eficacia local. El lavado con agua a presión (opción D) está contraindicado ya que agrava la inflamación y puede lesionar el conducto o el tímpano.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: B**

4.02.4.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos**

La opción correcta es la B. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gramnegativa que causa más del 70-80% de las otitis externas difusas y más del 95% de las otitis externas malignas necrotizantes en pacientes diabéticos. Su afinidad por medios húmedos y su producción de exotoxinas y proteasas facilitan la invasión dermoepidérmica y la osteólisis del hueso temporal.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

6.03.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos**

Es una oGGs externa clásica, de Gpo difuso, probablemente por Psdeudomonas aureginosa. Se trata con ciprofloxacino tópico. La otomicosis por cándida, Gene prurito generalmente con poco dolor y la secreción suele ser grumosa y blanquecina.

---

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D** **Disfonías agudas** 6.03.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Todas disfonía persistente se evalúa con nasofibrolaringoscopía (NFL). Además, el antecedente de cuerpo extraño y maniobra de Heimlich hacen sospechar una lesión laríngea o de las cuerdas vocales, parálisis cordal o cuerpo extraño residual, que se objetivarían con la NFL.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A** **Rinorreas agudas** 6.03.1.026 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A** **Otohematoma** 6.03.2.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Otohematoma" como urgencia clínica (6.03.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

**Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. En el Test de Weber, el sonido lateraliza hacia el oído contralateral (sano) en las hipoacusias sensorioneurales; al lateralizar al oído derecho, indica que el oído izquierdo es el hipoacúsico sensorioneural. Además, el Test de Rinne positivo bilateral (VA > VO) confirma que no hay alteración de la conducción en el oído izquierdo, ya que las hipoacusias sensorioneurales conservan un Rinne positivo (la vía aérea sigue siendo más eficiente que la vía ósea, aunque ambas estén proporcionalmente descendidas). Una hipoacusia de conducción izquierda (opciones A y E) mostraría Weber al oído izquierdo y Rinne negativo izquierdo.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: C**

**Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. La curva tipo B de Jerger es una curva plana, caracterizada por la ausencia de un pico móvil de compliance timpánica debido a la presencia de líquido no compresible (exudado o transudado seroso) en la cavidad del oído medio que impide la movilidad del tímpano ante los cambios de presión. Es el hallazgo timpanométrico clásico de la Otitis Media con Efusión (OME). La curva A es normal, la curva As indica rigidez (otoesclerosis), la curva C indica presión negativa por disfunción tubárica y la curva Ad indica luxación de cadena o tímpano monomérico.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: A**

**Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)**

6.03.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno de deglución" (6.03.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

**Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)**

6.03.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pregunta difícil y discutible, pero se resumen en "¿Cuál es el examen de elección ante la sospecha de hipoacusia congénita?" y la respuesta es potenciales evocados auditivos. Las emisiones otoacústicas son una opción más barata, como screening en los pacientes asintomáticos, pero si hay una sospecha, lo ideal es pedir potenciales evocados. Eso sí, a los 4 años es posible que el paciente ya coopere en la audiometría, por lo que técnicamente es una mala pregunta.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

La opción correcta es la C. El paciente presenta una Hipoacusia Sensorioneural Súbita (HSNS) derecha, una verdadera emergencia médica en ORL. La otoscopía normal descarta patología de oído externo o perforaciones, y el Weber al oído contralateral (izquierdo) con Rinne positivo confirma daño sensorioneural en el oído derecho. La única terapia con sólida evidencia que previene la sordera permanente es la corticoterapia oral en altas dosis (Prednisona 1 mg/kg/día por 10-14 días) iniciada de manera precoz en las primeras horas, complementada con audiometría urgente. Las opciones A y D son errores graves en oído con tímpano sano, y diferir la conducta (opciones B y E) conlleva secuelas irreversibles.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

La opción correcta es la B. La presbiacusia es la pérdida auditiva fisiológica relacionada con el envejecimiento, caracterizada por hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica y de predominio en frecuencias agudas, con dificultad desproporcionada para la discriminación fonémica en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más cuenta con Garantía Explícita en Salud (GES N° 56), que asegura el acceso a confirmación diagnóstica, entrega e implementación de audífonos y rehabilitación auditiva integral.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

La opción correcta es la C. El trauma acústico crónico por exposición laboral a ruido de alta intensidad (> 85 dB) produce un daño selectivo irreversible en las células ciliadas externas basales de la cóclea, lo que se traduce típicamente en la audiometría tonal como una caída o muesca ('escotoma acústico') simétrica en la frecuencia de 4000 Hz (y en menor medida 3000 o 6000 Hz), con recuperación relativa en los 8000 Hz.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

4.02.4.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

La opción correcta es la C. La Resonancia Magnética (RMN) de peñasco, conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso con medio de contraste (gadolinio) y secuencias finas potenciadas en T1 y T2 (CISS o FIESTA) es el examen de elección para detectar schwannomas vestibulares intracanaliculares incipientes (< 5 mm) que no son visibles en el TAC.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

6.03.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 92). Evalúa el manejo clínico de Hipoacusia neonatal según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: E**

6.03.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

Barotrauma: El caso describe un barotrauma típico, que se presenta en situaciones con cambios de presión atmosférica, como el buceo, viajes en avión, cambios bruscos de altitud, etc.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: E**

6.03.2.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 110). Evalúa el manejo clínico de Sordera súbita según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: A**

6.03.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndrome de apnea del sueño" (6.03.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: E**

6.03.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 141). Evalúa el manejo clínico de Síndrome respirador bucal según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: A**

6.03.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière**

Tríada de Ménière: vértigo episódico + hipoacusia neurosensorial fluctuante + tinnitus, todo ipsilateral, episodios de horas = enfermedad de Ménière. El VPPB dura segundos y no tiene hipoacusia.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: D**

6.03.2.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière**

Es una neuronitis vestibular clásica. La ausencia de síntomas auditivos descarta la parálisis cócleovestibular (que es una sordera súbita: cócleo + una neuronitis vestibular: vestibular) y el hídrops endolinfático (o enfermedad de Ménière). El vértigo postural se desencadena con movimientos de la cabeza.

---

## BLOQUE 3 RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: D** **Disfonías crónicas**

6.03.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A** **Sinusopatías crónicas**

6.03.1.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Parecía una rinitis crónica, con predominio de síntomas obstructivos, por lo que de primera línea se deben indicar corticoides tópicos.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A** **Otorragia**

6.03.2.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Otorragia" como urgencia clínica (6.03.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: C**

**Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. El paciente cumple el criterio diagnóstico formal de Rinosinusitis Bacteriana Aguda (RSBA) al presentar síntomas cardinales de rinosinusitis (obstrucción, rinorrea purulenta, dolor facial) persistentes por más de 10 días sin ninguna evidencia de mejoría clínica. Este criterio temporal de persistencia es el más sensible para diagnosticar sobreinfección bacteriana secundaria. La conducta de primera línea establecida por las guías clínicas es iniciar tratamiento antibiótico oral con Amoxicilina (o amoxicilina con ácido clavulánico) por 7 a 10 días, asociada a lavados con solución salina. Mantener solo analgésicos a los 12 días (opción B) prolonga el cuadro y expone a complicaciones.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

**Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La presencia de signos de afección postseptal como proptosis (exoftalmos) y oftalmoplejía con diplopía dolorosa, en ausencia de una colección delimitada visible o amaurosis, define el Estadio II de Chandler (Celulitis Orbitaria postseptal). En el Estadio I (celulitis preseptal), el edema se confina a la dermis palpebral anterior y los movimientos oculares están rigurosamente conservados sin proptosis. Requiere hospitalización inmediata, TAC con contraste y antibióticos endovenosos de amplio espectro.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Una vez identificado el punto sangrante específico en el plexo de Kiesselbach (porción anteroinferior del tabique nasal) tras una compresión digital no resolutiva y preparación con vasoconstrictor tópico, el tratamiento estándar de elección es la cauterización química puntual del vaso con un bastón de nitrato de plata al 75%. La cauterización debe aplicarse de forma suave y concéntrica alrededor del vaso sangrante. La opción D es un grave error médico que causa necrosis y perforación del cartílago septal; la opción E induce deglución de sangre y vómitos; y las opciones A y C son medidas desproporcionadas para una epistaxis anterior puntual.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La epistaxis posterior que requiere taponamiento con balón o sonda Foley es una situación clínica grave que exige HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA del paciente por riesgo de hipoxia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración. Además, la presencia de taponamiento posterior ocluye el ostium de drenaje de los senos paranasales y favorece la proliferación bacteriana en tejidos retenidos, lo que hace mandatorio el inicio de profilaxis antibiótica sistémica (habitualmente amoxicilina con ácido clavulánico o cefazolina) para prevenir el temible Síndrome de Shock Tóxico estafilocócico y la rinosinusitis aguda supurada. El balón se insufla con agua (nunca aire, que se desinfla por difusión) y solo con 8-10 mL para evitar necrosis tisular.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: B**

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. El Plexo de Kiesselbach (o Área de Little) es una red vascular ricamente anastomosada en la submucosa de la porción anteroinferior del tabique nasal, donde confluyen ramas de la arteria esfenopalatina, palatina mayor, labial superior y etmoidal anterior. Es el sitio anatómico de origen de más del 90% de las epistaxis anteriores.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

4.02.4.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. El cartílago del tabique nasal (cartílago cuadrangular) es avascular y se nutre exclusivamente por difusión a partir del pericondrio que lo recubre bilateralmente. Si se cauteriza de forma química o eléctrica ambas caras del tabique al mismo nivel simultáneamente, se destruye el aporte sanguíneo de ambos lados, provocando necrosis isquémica del cartílago subyacente y una perforación septal permanente, complicación grave y de difícil reparación quirúrgica.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A**

6.03.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epistaxis a repetición" (6.03.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: A**

6.03.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Epistaxis leve" (6.03.1.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

6.03.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

**Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Epistaxis masiva" como urgencia clínica (6.03.2.011), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

4.02.4.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal**

La opción correcta es la B. La presencia de una tumefacción abombada violácea y fluctuante en el tabique nasal tras un traumatismo agudo es la manifestación clínica típica del Hematoma Septal. Es una emergencia otorrinolaringológica: el cartílago septal sufre necrosis isquémica por desprendimiento del pericondrio en menos de 24 a 48 horas si no se descomprime, lo que provocaría la pérdida de soporte de la pirámide nasal (deformidad en silla de montar). La conducta inmediata ineludible es el drenaje quirúrgico de los coágulos mediante incisión del mucopericondrio, colocación de taponamiento anterior bilateral compresivo y cobertura antibiótica. Diferir la conducta (opción C) o usar descongestionantes (opción A) conduce a secuelas estéticas y funcionales irreparables.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

6.03.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal**

El tratamiento de los pólipos nasales es con corticoides orales. Si solo hubiese tenido la rinitis alérgica, con obstrucción, pero sin pólipos, el tratamiento serían los corticoides tópicos.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

6.03.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Fractura nasal reciente" como urgencia clínica (6.03.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales**

La opción correcta es la B. De acuerdo con la clasificación de consenso ARIA, el paciente tiene síntomas ≥ 4 días a la semana durante ≥ 4 semanas (lo que define el patrón 'Persistente') y presenta alteración del sueño y deterioro de su rendimiento de estudio (lo que define la categoría 'Moderada a Severa'). Para la rinitis alérgica persistente moderada-severa, la terapia de primera línea más eficaz y recomendada son los Corticoides Intranasales (fluticasona, mometasona o ciclesonida), que actúan sobre todos los mediadores inflamatorios y son superiores a los antihistamínicos orales en el alivio de la obstrucción nasal.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

4.02.4.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales**

La opción correcta es la B. Los vasoconstrictores tópicos alfa-adrenérgicos (oximetazolina, tramazolina, fenilefrina) producen taquifilaxia y vasodilatación paradójica de rebote ('rinitis medicamentosa') si se utilizan por más de 5 a 7 días consecutivos. La conducta obligatoria consiste en la suspensión inmediata y definitiva del fármaco vasoconstrictor y el inicio de corticoides tópicos intranasales (como fluticasona o mometasona) para reducir la hipertrofia e inflamación endotelial de los cornetes.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

6.03.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Obstrucción nasal crónica" (6.03.1.016), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

## BLOQUE 4 FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Estridor laríngeo** 6.03.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 86). Evalúa el manejo clínico de Estridor laríngeo según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A** **Tinitus** 6.03.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tinitus" (6.03.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A** **Perforación timpánica traumática** 6.03.2.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 44). Evalúa el manejo clínico de Perforación timpánica traumática según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: C**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

La opción correcta es la C. El paciente suma exactamente 5 puntos en la escala de McIsaac: fiebre > 38°C (+1), exudado amigdalino (+1), adenopatías anteriores sensibles (+1), ausencia de tos (+1) y edad de 3 a 14 años (+1). Con 5 puntos, la probabilidad de infección por Streptococcus pyogenes supera el 50-60%, estando formalmente indicado el inicio inmediato de tratamiento antibiótico de primera línea: Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única o Amoxicilina oral (50 mg/kg/día) durante 10 días completos con el objetivo primordial de prevenir la fiebre reumática aguda.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. Es una regla de oro de la infectología y pediatría: el tratamiento antibiótico adecuado de la faringitis estreptocócica previene de manera categórica la aparición de la Fiebre Reumática Aguda y sus secuelas valvulares cardíacas, siempre que se administre penicilina benzatina o se completen 10 días de antibióticos orales. Por el contrario (opción A), los antibióticos NO previenen la Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE), la cual depende de una respuesta inmune mediada por inmunocomplejos y antígenos nefritogénicos que se activa independientemente de la erradicación bacteriana. La opción E es falsa: el SBHGA mantiene un 100% de sensibilidad a la penicilina.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La aparición de un exantema máculo-papular eritematoso difuso (rash por aminopenicilinas) en más del 90-95% de los pacientes con Mononucleosis Infecciosa por Virus de Epstein-Barr (EBV) tras recibir amoxicilina o ampicilina es un efecto inmunomediado clásico no alérgico. La presencia de odinofagia prolongada, exudado amigdalino, adenopatías en cadena cervical posterior y epitrocleares, sumado a esplenomegalia, confirma el síndrome mononucleósico.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: C**

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

4.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La opción correcta es la C. Ante un antecedente fidedigno de reacción alérgica grave anafiláctica mediada por IgE (edema laríngeo, broncoespasmo o shock anafiláctico) a las penicilinas, están terminantemente contraindicados todos los antibióticos betalactámicos, incluyendo aminopenicilinas (opciones A y E) y cefalosporinas (opciones B y D) por riesgo de reacción anafiláctica cruzada potencialmente mortal. En esta situación clínica, los macrólidos (Azitromicina 500 mg/día por 5 días o Claritromicina 250-500 mg cada 12 horas por 10 días) constituyen la alternativa terapéutica formal de elección.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

6.03.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Amigdalitis aguda" (6.03.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina**

6.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Amigdalitis crónica" (6.03.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El cuadro clínico corresponde a un Absceso Periamigdalino derecho (quinsy), caracterizado por la tríada clásica de trismus, voz en papa caliente y desviación contralateral de la úvula provocada por la colección purulenta en el espacio periamigdalino. La conducta de elección que proporciona confirmación diagnóstica y alivio sintomático inmediato es la punción aspirativa con aguja o la incisión y drenaje en el punto de máxima fluctuación del pilar anterior, asociada al inicio inmediato de antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro con cobertura para anaerobios (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol). Mantener tratamiento oral (opción A) es una conducta errónea ante una colección purulenta fascial.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: A**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la A. En niños menores de 5 años, la inflamación y supuración de los ganglios linfáticos retrofaríngeos de Gilette origina el Absceso Retrofaríngeo. Sus manifestaciones cardinales son fiebre, sialorrea, rigidez de nuca con tortícolis, estridor inspiratorio y ensanchamiento del espacio prevertebral visible en la radiografía lateral de cuello en inspiración. La complicación más grave y potencialmente letal es la propagación de la infección purulenta a través del 'espacio peligroso' (danger space) hacia el tórax, originando una Mediastinitis Necrotizante Descendente con shock séptico y alta mortalidad. Requiere hospitalización inmediata en UCI, TAC de cuello con contraste y drenaje quirúrgico en quirófano.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El trismus en las infecciones faríngeas profundas se debe a la inflamación por contigüidad, espasmo e hipertonía refleja de los músculos masticadores, específicamente del músculo pterigoideo interno (o medial), el cual se sitúa inmediatamente lateral al músculo constrictor superior de la faringe y al espacio periamigdalino.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El paciente presenta una Angina de Ludwig, una celulitis gangrenosa rápidamente progresiva de los espacios submandibular, sublingual y submentoniano originada típicamente a partir de focos odontogénicos inferiores. El signo de máxima alarma es la induración leñosa del piso de boca que eleva y propulsa la lengua hacia la orofaringe posterior, causando una obstrucción mecánica inminente y letal de la vía aérea superior. La prioridad clínica número uno indiscutida es el aseguramiento expedito de la vía aérea (mediante intubación con fibrobroncoscopio o traqueostomía de urgencia), antes de intentar cualquier procedimiento quirúrgico de drenaje o exámenes complementarios.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

6.03.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un absceso periamigdalino clásico.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

6.03.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso profundo de cuello" como urgencia clínica (6.03.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

**Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo**

6.03.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Absceso retrofaríngeo" como urgencia clínica (6.03.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

**Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas**

4.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. El paciente presenta un Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) infantil severo con repercusión en el desarrollo físico y amígdalas grado 4 que colapsan la orofaringe. El SAHOS pediátrico documentado secundario a hipertrofia de amígdalas y adenoides es la indicación quirúrgica absoluta indiscutida de adenoamigdalectomía. Postergar la intervención quirúrgica (opción D) expone al niño a fallo de medro, alteraciones ortodóncicas craneofaciales irreversibles y riesgo de hipertensión pulmonar / cor pulmonale crónico.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: D**

**Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke**

6.03.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene clínica de rinitis. Por ser más intensa en las mañanas y con los cambios de temperatura, es de tipo vasomotora. Otras cosas clásicas de la rinitis vasomotora es que empeora con el estrés, con alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer se presenta como obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral. Los pólipos se ven en pacientes jóvenes y suelen ser bilaterales, con marcada obstrucción y sí pueden tener rinorrea o sinusitis secundarias.

---

## BLOQUE 5 CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Odinofagias agudas** 6.03.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Odinofagias agudas" (6.03.1.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** **Atresia coanal congénita** 6.03.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Atresia coanal congénita" como urgencia clínica (6.03.2.005), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

4.02.7.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. La pila de botón en una cavidad mucosa como la fosa nasal o el CAE es una emergencia quirúrgica de máxima prioridad debido a la rápida producción de quemaduras químicas alcalinas graves por electrólisis y fuga de hidróxido de potasio, las cuales pueden ocasionar perforación del cartílago septal en menos de 2 horas. La extracción debe realizarse de forma inmediata por personal entrenado con instrumental específico (gancho romo introducido por detrás del objeto). Está estrictamente contraindicada la irrigación con agua o suero (opción A) porque los líquidos actúan como electrolito conductor que acelera catastróficamente la corriente eléctrica y la destrucción tisular.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: B**

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

4.02.7.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La opción correcta es la B. En pediatría, la presencia de rinorrea purulenta, persistente, UNILATERAL y con OLOR FÉTIDO de varias semanas de evolución en un niño pequeño es el cuadro clínico clásico y patognomónico de un Cuerpo Extraño Nasal retenido y desapercibido (como fragmentos de esponja, papel o goma). La impactación del objeto bloquea el drenaje fisiológico de la mucosa y genera sobreinfección bacteriana local crónica anaerobia responsable de la fetidez extrema. Requiere rinoscopía anterior o nasofibroscopía inmediata para visualización y extracción.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A**

6.03.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño en el oído" como urgencia clínica (6.03.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

6.03.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño en el esófago" como urgencia clínica (6.03.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: D**

6.03.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

E? Por la tos áfona y el estridor es un cuerpo extraño laríngeo, pero por la sialorrea y la reticencia a comer era esofágico. Esta pregunta inducía a error. Yo marqué laríngeo, porque le di más importancia a los síntomas laríngeos.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

6.03.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Cuerpo extraño nasal" como urgencia clínica (6.03.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

4.02.5.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo**

La opción correcta es la B. La presentación clínica de aumento de volumen y dolor paroxístico desencadenado por el estímulo alimentario ('cólico salival') es patognomónica de Sialolitiasis. El 80 a 90% de los cálculos salivales se originan en la glándula submandibular y se impactan en su conducto excretor principal, el conducto de Wharton, el cual discurre por el piso de la boca hasta desembocar en las carúnculas sublinguales a ambos lados del frenillo lingual.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

4.02.5.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

**Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo**

La opción correcta es la B. El tumor más frecuente de las glándulas salivales es el Adenoma Pleomorfo (tumor mixto benigno), el cual asienta en más del 80% de los casos en la glándula parótida. Su presentación clínica es clásica: nódulo parotídeo indoloro, móvil, de consistencia elástica y crecimiento lento de meses o años, con integridad rigurosa de la función del nervio facial (VII par). El tratamiento de elección estándar es la Parotidectomía Superficial con identificación, disección y preservación del nervio facial. La enucleación simple (opción D) está formalmente contraindicada debido a que presenta un riesgo de recidiva local superior al 40% y riesgo de transformación maligna a carcinoma.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: C**

6.03.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo**

Es una sialoliGasis clásica. La obstrucción produce dolor y aumento de volumen súbitos. La desobstrucción puede ser intermitente. El tratamiento suele ser con analgésico y, si se ve el cálculo a la salida del conducto salival, es posible reGrarlo.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

4.02.6.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. En un adulto fumador mayor de 40 años, una masa cervical pétrea fija es una metástasis ganglionar de carcinoma epidermoide de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. El método diagnóstico citológico de primera línea indiscutido es la Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía, la cual permite tipificar la neoplasia con alta sensibilidad sin diseminar células tumorales. Al mismo tiempo, está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar una biopsia incisional o abierta del ganglio sin haber evaluado la vía aérea superior y sin PAAF previa, debido a que la apertura quirúrgica rompe las fascias cervicales, produce siembra tumoral extracapsular masiva, deteriora el pronóstico y complica gravemente el posterior vaciamiento ganglionar cervical radical.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

4.02.6.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Especialista GES

La opción correcta es la B. La otalgia referida o refleja unilateral en presencia de un oído completamente sano (otoscopía normal) es una de las banderas rojas oncológicas más características de los tumores malignos del tracto aerodigestivo superior. El dolor se transmite por vía refleja a través de ramos sensitivos de los nervios craneales que inervan tanto la orofaringe/hipofaringe como el oído (el nervio glosofaríngeo a través del nervio timpánico de Jacobson, y el nervio vago a través del nervio auricular de Arnold). En todo adulto, especialmente si tiene antecedentes de tabaco o alcohol, este hallazgo exige nasofibroscopía inmediata para buscar un cáncer primario en amígdalas, base de lengua o laringe.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

6.03.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de boca, labios y orofaringe" (6.03.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: C**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

6.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un clásico cáncer de hipofaringe. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas. El cáncer de esófago presenta disfagia lógica, sin los otros síntomas.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: C**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

6.03.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía (más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este caso).

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

6.03.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer nasosinusal" (6.03.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: D**

**Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical**

6.03.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un quiste del conducto Grogloso clásico. La ubicación en la línea media, suprahioidea es lo más característico.

---

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 15 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 2

# OFTALMOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Ojo Rojo, Glaucoma & Retina

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Oftalmología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR** | | | | | |
| 2.01.1.097 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5, Q6 | Tomo 15 · 15.1 (Pág. 5) |
| 6.02.1.002 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12 | Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11) |
| 6.02.1.004 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q13 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.005 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q9 | Tomo 15 · 15.2 (Pág. 9) |
| 6.02.1.006 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 15 · 15.4 (Pág. 13) |
| 6.02.1.007 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q10 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.008 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q11 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.009 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.011 | Estrabismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 15 · C.23 (Pág. 50) |
| 6.02.1.015 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.019 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q15 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.024 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 15 · C.16 (Pág. 36) |
| 6.02.1.029 | Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.007 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.010 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR** | | | | | |
| 2.01.1.005 | Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35, Q36 | Tomo 15 · 15.8 (Pág. 26) |
| 6.02.1.002 | Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27, Q31, Q32 | Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11) |
| 6.02.1.012 | Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 15 · C.24 (Pág. 52) |
| 6.02.1.013 | Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33, Q34 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.014 | Hifema | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.021 | Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q23 | Tomo 15 · 15.5 (Pág. 15) |
| 6.02.2.005 | Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.006 | Hemorragia vítrea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 3: GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO** | | | | | |
| 6.02.1.003 | Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 | Tomo 15 · 15.10 (Pág. 33) |
| 6.02.1.018 | Obstrucción completa de la vía lacrimal | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.031 | Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.003 | Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.004 | Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49, Q50, Q52, Q53, Q54 | Tomo 15 · 15.9 (Pág. 28) |
| 6.02.2.008 | Heridas de párpados | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA** | | | | | |
| 6.02.1.001 | Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68, Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 15 · 15.15 (Pág. 50) |
| 6.02.1.010 | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.020 | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Derivar** · Seg: **Control** | GES | Q66, Q67 | Tomo 15 · 15.14 (Pág. 45) |
| 6.02.1.022 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.023 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.025 | Tumores de conjuntiva | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.027 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Derivar** · Seg: **Control** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 15 · 15.12 (Pág. 39) |
| 6.02.2.009 | Parálisis III par + midriasis | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 15 · C.21 (Pág. 46) |
| **BLOQUE 5: TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA** | | | | | |
| 1.01.1.015 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83, Q84 | Tomo 01 · 5.1 (Pág. 53) |
| 6.02.1.016 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85, Q86 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.017 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87, Q88, Q89 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.026 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q90 | Tomo 15 · C.20 (Pág. 44) |
| 6.02.1.028 | Tumores de párpado | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73, Q74 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.030 | Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 15 · 15.17 (Pág. 56) |
| 6.02.2.001 | Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q75 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.002 | Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76, Q77 | Tomo 15 · 15.16 (Pág. 54) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Oftalmología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.1.015 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83, Q84 | Tomo 01 · 5.1 (Pág. 53) |
| 2.01.1.005 | Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35, Q36 | Tomo 15 · 15.8 (Pág. 26) |
| 2.01.1.097 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3, Q4, Q5, Q6 | Tomo 15 · 15.1 (Pág. 5) |
| 6.02.1.001 | Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68, Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 15 · 15.15 (Pág. 50) |
| 6.02.1.002 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q12, Q24, Q25, Q26, Q27, Q31, Q32 | Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11) |
| 6.02.1.003 | Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 | Tomo 15 · 15.10 (Pág. 33) |
| 6.02.1.004 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q13 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.005 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q9 | Tomo 15 · 15.2 (Pág. 9) |
| 6.02.1.006 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 15 · 15.4 (Pág. 13) |
| 6.02.1.007 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q10 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.008 | Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q11 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.009 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.010 | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.011 | Estrabismo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 15 · C.23 (Pág. 50) |
| 6.02.1.012 | Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 15 · C.24 (Pág. 52) |
| 6.02.1.013 | Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q33, Q34 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.014 | Hifema | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.015 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.016 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q85, Q86 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.017 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87, Q88, Q89 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.018 | Obstrucción completa de la vía lacrimal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.019 | Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q15 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.020 | Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central | Dx: **Sospecha** Tx: **Derivar** · Seg: **Control** | GES | Q66, Q67 | Tomo 15 · 15.14 (Pág. 45) |
| 6.02.1.021 | Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q23 | Tomo 15 · 15.5 (Pág. 15) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02.1.022 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.023 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.024 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7 | Tomo 15 · C.16 (Pág. 36) |
| 6.02.1.025 | Tumores de conjuntiva | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.026 | Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q90 | Tomo 15 · C.20 (Pág. 44) |
| 6.02.1.027 | Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Derivar** · Seg: **Control** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64 | Tomo 15 · 15.12 (Pág. 39) |
| 6.02.1.028 | Tumores de párpado | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73, Q74 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.029 | Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.1.030 | Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 15 · 15.17 (Pág. 56) |
| 6.02.1.031 | Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q51 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.001 | Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q75 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.002 | Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q76, Q77 | Tomo 15 · 15.16 (Pág. 54) |
| 6.02.2.003 | Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.004 | Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49, Q50, Q52, Q53, Q54 | Tomo 15 · 15.9 (Pág. 28) |
| 6.02.2.005 | Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.006 | Hemorragia vítrea | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.007 | Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo | Dx: **Sospecha**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.008 | Heridas de párpados | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |
| 6.02.2.009 | Parálisis III par + midriasis | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 15 · C.21 (Pág. 46) |
| 6.02.2.010 | Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides) | Dx: **Específico**<br>Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

PREGUNTA 1 6.02.1.011

**1.** **Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos y movilidad ocular sin alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar fondo de ojo
B) Derivar a oftalmólogo pediátrico
C) Indicar parches oculares intermitentes
D) Solicitar TAC de órbitas
E) Mantener el control habitual del niño sano

PREGUNTA 2 6.02.1.029

**2.** **Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinoblastoma
B) Glaucoma congénito
C) Catarata congénita
D) Retinopatía del prematuro
E) Tumor de órbita

PREGUNTA 3 2.01.1.097

**3.** **Un hombre de 62 años consulta en el servicio de urgencias por dolor ocular derecho intenso de inicio brusco hace 3 horas, asociado a náuseas y vómitos. Refiere ver halos de colores alrededor de las luces. Al examen: inyección periquerática severa, córnea con pérdida difusa del brillo ("en vidrio esmerilado"), pupila derecha en midriasis media fija no reactiva y consistencia ocular pétrea a la palpación digital. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata más adecuada?**

A) Uveítis anterior aguda; indicar colirio de atropina al 1% y derivar a policlínico
B) Conjuntivitis hiperaguda; indicar ceftriaxona intramuscular y lavado con suero
C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; iniciar manitol endovenoso, acetazolamida oral y timolol tópico, y derivar de urgencia
D) Queratitis bacteriana severa; indicar colirios reforzados de vancomicina y oclusión
E) Desprendimiento de retina; reposo en cama en posición decúbito supino y derivar vía GES

PREGUNTA 4 2.01.1.097

**4.** **Una mujer de 24 años consulta por ojo izquierdo rojo de 24 horas de evolución, asociado a sensación de arenilla y prurito leve. Al examen: agudeza visual 20/20 en ambos ojos, inyección conjuntival periférica difusa con vasos móviles que respeta el limbo esclerocorneal, secreción mucosa escasa, pupilas isocóricas y reactivas, córnea transparente. ¿Cuál es la conducta más adecuada en la atención primaria?**

A) Derivar de urgencia a oftalmología en menos de 2 horas
B) Indicar colirio antibiótico (cloranfenicol al 0.5%), medidas de higiene y control ambulatorio si no mejora
C) Indicar colirio de dexametasona al 0.1% cada 4 horas por 7 días
D) Solicitar tomografía computarizada de órbita y encéfalo
E) Realizar tonometría aplanática y prueba de provocación con midriáticos

PREGUNTA 5 2.01.1.097

**5.** **Un paciente de 45 años con antecedente de espondiloartritis seronegativa consulta por dolor sordo en ojo izquierdo, fotofobia intensa y lagrimeo. Al examen se constata inyección periquerática, agudeza visual OI 20/40 y pupila izquierda miótica de 2 mm que responde escasamente a la luz, a diferencia de la derecha que mide 4 mm. La tinción con fluoresceína es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Uveítis anterior aguda
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Úlcera corneal herpética
D) Conjuntivitis alérgica estacional
E) Epiescleritis simple

PREGUNTA 6 2.01.1.097

**6.** **Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo, dolor, pérdida de visión ni secreción ocular. Al examen: hemorragia plana homogénea que oculta los vasos esclerales en la conjuntiva bulbar nasal, agudeza visual 20/20 bilateral, pupilas normales y córnea transparente. Presión arterial: 125/80 mmHg. ¿Cuál es la conducta indicada?**

A) Indicar ácido tranexámico oral y reposo absoluto
B) Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10-14 días y no indicar fármacos tópicos
C) Instilar colirio de fenilefrina para lograr vasoconstricción inmediata
D) Realizar paracentesis conjuntival para evacuar el hematoma
E) Derivar de inmediato para fotocoagulación láser

PREGUNTA 7 6.02.1.024

**7.** **Paciente de 40 años con ojo rojo, sensación de arenilla, lagrimeo y fotofobia desde hace 3 meses. Usa lentes de contacto hace años. Antecedente de artritis reumatoide. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis sicca)
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Úlcera corneal por Acanthamoeba
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

PREGUNTA 8 6.02.2.007

**8.** **Niño con aumento volumen de párpado, eritema, y secreción purulenta, no puede abrir el ojo: a. Celulitis periorbitaria (sin oftalmoplejia, dolor al mover el ojo, proptosis, disminución de la agudeza visual) Según yo salia que no podía abrir el ojo, decía literalmente “dolor al-1hh1-examen oftalmológico, eso se puede ƒasumir como dolor a la oculomotilidad)**

B) celulitis orbitaria
C) Chalazion infectado
C) Control sano habitual
D) Derivar a especialista
E) Hospitalizar

PREGUNTA 9 6.02.1.005

**9.** **Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. El diagnóstico más probable es:**

A) Alergia al cloranfenicol
B) Celulitis orbitaria
C) Obstrucción lacrimal
D) Chalazion
E) Absceso tarsal

PREGUNTA 10 6.02.1.007

**10.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Conjuntivitis no infecciosa · 6.02.1.007] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conjuntivitis no infecciosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 11 6.02.1.008

**11.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Conjuntivitis viral no complicada · 6.02.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conjuntivitis viral no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 12 6.02.1.002

**12.** **Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Amoxicilina
B) Azitromicina
C) Aciclovir
D) Mupirocina
E) Dexametasona

PREGUNTA 13 6.02.1.004

**13.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Chalazion · 6.02.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Chalazion. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 14 6.02.1.009

**14.** **Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epifora. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar antibióticos orales
B) Indicar masajes y compresiones locales
C) Indicar corticoides tópicos
D) Indicar antibióticos en colirios
E) Resolver quirúrgicamente

PREGUNTA 15 6.02.1.019

**15.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Orzuelo no complicado · 6.02.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Orzuelo no complicado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 6.02.1.006

**16.** **Una paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epifora y secreción mucosa, que a veces se vuelve purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma agudo
B) Blefaritis
C) Uveítis
D) Dacriocistitis
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

PREGUNTA 17 6.02.1.015

**17.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Leucoma corneal · 6.02.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Leucoma corneal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 6.02.2.010

**18.** **Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Conjuntivitis bacteriana

B) Úlcera corneal

C) Uveítis aguda

D) Glaucoma agudo

E) Blefaritis

## BLOQUE 2 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

PREGUNTA 19 6.02.1.014

**19.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hifema · 6.02.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hifema. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 6.02.2.006

**20.** **Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo izquierdo solo puede contar dedos. Al examen físico no se ven alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. El diagnóstico más probable es:**

A) Trombosis de la vena central de la retina

B) Desprendimiento de retina

C) Neuritis óptica

D) Embolia de arteria central de la retina

E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 21 6.02.1.021

**21.** **Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen Fsico, presenta epífora y ojo rojo derecho de 8po central. Como antecedente, 8ene as8gma8smo y es usuaria de lentes de contacto. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

A) Fondo de ojo

B) Tonometría ocular

C) TAC de órbitas

D) Tinción con fluoresceína

E) Gonioscopía

PREGUNTA 22 6.02.1.021

**22.** **Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a sensación leve de arenilla, sin dolor intenso ni baja de visión. Al examen: agudeza visual 20/20 bilateral, inyección vascular roja brillante triangular en el sector temporal de la conjuntiva bulbar. Tras instilar una gota de fenilefrina al 2.5%, la hiperemia vascular desaparece casi por completo a los 10 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Escleritis necrotizante; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa

B) Epiescleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente

C) Glaucoma agudo incipiente; indicar pilocarpina al 2% en colirio

D) Uveítis anterior aguda; solicitar resonancia magnética cerebral

E) Queratitis estromal herpética; iniciar aciclovir endovenoso

PREGUNTA 23 6.02.1.021

**23.** **Un paciente de 60 años con antecedente de granulomatosis con poliangeítis (Wegener) consulta por dolor ocular lancinante en ojo derecho que le impide dormir y le irradia a la frente. Al examen físico se aprecia una zona nodular sobreelevada de color violáceo oscuro en la esclera superior que no se modifica con la instilación de fenilefrina tópica. ¿Cuál es la complicación más temida si este cuadro no recibe tratamiento sistémico oportuno?**

A) Catarata cortical senil bilateral

B) Necrosis y adelgazamiento escleral con perforación del globo ocular (escleromalacia)

C) Desprendimiento de retina regmatógeno por desgarro gigante

D) Oclusión de la vena central de la retina

E) Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica

PREGUNTA 24 6.02.1.002

**24.** **Una paciente de 67 años acude a un SAPU por cefalea hemicraneana izquierda intensa de 2 horas de evolución, acompañada de vómitos reiterados y visión borrosa ipsilateral. El médico de turno sospecha migraña con aura o accidente cerebrovascular. Sin embargo, al examen ocular destaca inyección ciliar severa, edema corneal en vidrio deslustrado, pupila izquierda en midriasis media de 5 mm no reactiva a la luz y marcado endurecimiento del globo ocular a la palpación digital comparativa. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea más indicada mientras se gestiona su traslado urgente?**

A) Sumatriptán subcutáneo y metoclopramida endovenosa

B) Manitol endovenoso al 20%, acetazolamida oral y timolol tópico

C) Atropina en colirio al 1% y dexametasona subconjuntival

D) Pilocarpina tópica en dosis masivas continuas cada 2 minutos

E) Heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico

PREGUNTA 25 6.02.1.002

**25. Tras compensar médicamente con éxito una crisis de glaucoma agudo por cierre angular en el ojo derecho de un paciente de 60 años, reduciéndose la PIO a 16 mmHg, el oftalmólogo planifica el tratamiento definitivo con iridotomía láser YAG. ¿Cuál es la indicación respecto al ojo izquierdo contralateral, que actualmente se encuentra completamente asintomático con PIO de 14 mmHg?**

A) Observación clínica anual sin ninguna intervención invasiva
B) Realizar iridotomía periférica con láser YAG profiláctica en el ojo izquierdo
C) Indicar tratamiento de por vida con colirio de atropina profiláctica
D) Indicar pilocarpina tópica diaria únicamente en caso de que aparezca dolor
E) Indicar cirugía de desprendimiento de retina preventiva

PREGUNTA 26 6.02.1.002

**26. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está CONTRAINDICADO administrar a un paciente con sospecha o antecedentes de ángulo iridocorneal estrecho sin iridotomía previa?**

A) Paracetamol oral
B) Tropicamida en colirio oftálmico
C) Timolol colirio al 0.5%
D) Latanoprost colirio
E) Amoxicilina oral

PREGUNTA 27 6.02.1.002

**27. Un hombre de 55 años con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo cerrado consulta a su médico porque leyó en el prospecto de un fármaco que la pilocarpina al 2% en colirio puede provocarle efectos no deseados. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la pilocarpina ayuda a resolver la crisis de cierre angular?**

A) Induce midriasis máxima que relaja el iris hacia el centro de la pupila
B) Inhibe la producción de humor acuoso a nivel de los procesos ciliares
C) Estimula los receptores muscarínicos induciendo miosis, lo que estira y tracciona la raíz del iris alejándola del trabéculo
D) Aumenta el drenaje uveoescleral de la linfa retiniana
E) Produce deshidratación hiperosmolar del cuerpo vítreo

PREGUNTA 28 6.02.1.012

**28. Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se realiza medición del diámetro corneal, que resulta 14 mm (VN: 10 a 12 mm) y prueba de fluoresceína, con aclaramiento de 5 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A) Glaucoma congénito
B) Atresia de la vía lagrimal
C) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
D) Ambliopía
E) Retinopatía del prematuro

PREGUNTA 29 6.02.1.012

**29. Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y au- mento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinoblastoma
B) Macrocórnea
C) Glaucoma congénito
D) Atresia lagrimal
E) Catarata congénita

PREGUNTA 30 6.02.2.005

**30. Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma agudo
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Cefalea cluster
D) Celulitis orbitaria
E) Accidente vascular encefálico

PREGUNTA 31 6.02.1.002

**31. Un hombre de 58 años, asintomático, acude a chequeo oftalmológico por tener un padre ciego por glaucoma. Su agudeza visual es 20/20 bilateral. En el fondo de ojo se constata una relación excavación/papila de 0.7 en el ojo derecho y 0.65 en el izquierdo, con adelgazamiento del anillo neurorretiniano inferior. La tonometría marca 24 mmHg en ambos ojos y la campimetría computarizada revela un escalón nasal en ojo derecho. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea de elección para este paciente?**

A) Pilocarpina colirio al 2% cada 6 horas
B) Latanoprost colirio al 0.005% una vez al día en la noche
C) Acetazolamida oral 250 mg cada 8 horas en forma indefinida
D) Atropina colirio al 1% cada 12 horas
E) Nafazolina colirio cada 8 horas

PREGUNTA 32 6.02.1.002

**32. ¿Cuál es la razón principal por la cual el glaucoma crónico de ángulo abierto suele diagnosticarse tardíamente en la práctica clínica ambulatoria?**

A) Cursa con dolor ocular intermitente que el paciente confunde con fatiga visual
B) La pérdida del campo visual comienza en la periferia respetando la agudeza visual central hasta fases muy avanzadas
C) Produce opacidad temprana de la córnea que impide la visión del fondo de ojo
D) Se asocia de forma constante a episodios de ojo rojo bilateral evanescente
E) Porque no existen tratamientos médicos capaces de detener su evolución

PREGUNTA 33 6.02.1.013

**33. Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0.7 en el ojo derecho y en la gonioscopía se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía diabética
B) Neuritis óptica
C) Glaucoma crónico
D) Coriorretinitis
E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 34 6.02.1.013

**34. Una paciente de 50 años se realiza una tonomotría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteracios. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Neuropatía óptica
C) Glaucoma crónico
D) Catarata
E) Desprendimiento de retina

PREGUNTA 35 2.01.1.005

**35.** **Un paciente de 65 años, con antecedentes de asma bronquial en tratamiento crónico con corticoides inhalados y pulsos orales frecuentes de prednisona, consulta por disminución rápida de la agudeza visual en ambos ojos de 6 meses de evolución, que le molesta especialmente a la luz del sol brillante. Al examen físico se aprecia una agudeza visual de 20/80 bilateral y en la oftalmoscopía se observa una opacidad densa y granular situada en el polo posterior del cristalino, justo por delante de la cápsula. ¿Cuál es el tipo de catarata más probablemente presente en este paciente?**

A) Catarata cortical anterior
B) Catarata subcapsular posterior
C) Catarata nuclear dura
D) Catarata traumática en roseta
E) Catarata congénita zonular

PREGUNTA 36 2.01.1.005

**36.** **¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar de primera elección en la actualidad para el tratamiento de la catarata senil en el sistema de salud chileno?**

A) Extracción intracapsular con crioquinectomía dejando el ojo afáquico
B) Facoemulsificación por ultrasonido con implante de lente intraocular plegable en saco capsular
C) Iridotomía periférica con láser YAG bilateral
D) Trabeculectomía con antimetabolitos
E) Vitrectomía pars plana posterior con intercambio gas-líquido

## BLOQUE 3 GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

PREGUNTA 37 6.02.1.018

**37.** **Un niño de 4 meses de edad consulta por epifora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial, con borramiento de la hendidura palpebral y reflujo al comprimir el saco lagrimal. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma congénito
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Atresia lagrimal congénita
D) Queratitis por Chlamydia trachomatis
E) Dacriocele

PREGUNTA 38 6.02.2.008

**38.** **[URGENCIA: Heridas de párpados · 6.02.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas de párpados. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 6.02.1.003

**39.** **Pregunta 171 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma crónico
B) Catarata
C) Degeneración macular relacionada con la edad
D) Vicio de refracción
E) Atrofia del nervio óptico

PREGUNTA 40 6.02.1.003

**40.** **Un hombre de 48 años, miope de -7 dioptrías, consulta en urgencias por ver destellos luminosos ("fotopsias") y una lluvia de puntos oscuros flotantes en su ojo izquierdo desde hace 2 días. Hace 6 horas comenzó a notar una sombra oscura fija que le tapa la mitad superior del campo visual. El ojo no está rojo ni duele. La agudeza visual en dicho ojo es 20/25. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica inmediata?**

A) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; administrar manitol endovenoso y pilocarpina
B) Desprendimiento de retina regmatógeno con mácula aplicada; indicar reposo absoluto y derivar de urgencia para cirugía GES
C) Oclusión de la arteria central de la retina; realizar masaje ocular digital inmediato
D) Neuritis óptica retrobulbar; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa
E) Crisis migrañosa con aura retiniana; prescribir paracetamol y reposo en habitación oscura

PREGUNTA 41 6.02.1.003

**41.** **¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento de retina traccional?**

A) El regmatógeno requiere una rotura o desgarro retiniano que permite el paso de humor vítreo líquido, mientras que el traccional es producido por membranas fibrovasculares que traccionan mecánicamente la retina sin desgarro
B) El regmatógeno es doloroso y con ojo rojo, mientras que el traccional es indoloro
C) El traccional se opera siempre con láser superficial y el regmatógeno solo con corticoides orales
D) El regmatógeno se produce por acumulación de exudados inflamatorios y el traccional por hipertensión intraocular
E) No existe diferencia; son dos términos sinónimos para la misma patología

PREGUNTA 42 6.02.1.003

**42.** **Una mujer de 55 años, previamente sana, presenta repentinamente la aparición de múltiples moscas volantes y destellos luminosos en el ojo derecho. Acude a evaluación oftalmológica el mismo día. La oftalmoscopía indirecta con pupila dilatada revela un desgarro retiniano periférico en herradura sin líquido subretiniano (sin desprendimiento aún). ¿Cuál es el tratamiento profiláctico de elección para evitar que desarrolle un desprendimiento de retina?**

A) Vitrectomía pars plana urgente con infusión de aceite de silicona
B) Fotocoagulación con láser de argón alrededor del desgarro
C) Inyección intravítrea de triamcinolona
D) Corticoides orales en dosis de 1 mg/kg/día por 1 mes
E) Observación clínica semanal sin intervención

PREGUNTA 43 6.02.1.003

**43. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con el peor pronóstico visual final en un paciente sometido a cirugía de desprendimiento de retina?**

A) Desprendimiento localizado en cuadrantes superiores
B) Compromiso de la mácula con desprendimiento foveal (mácula off) de más de una semana de evolución
C) Edad menor a 40 años
D) Uso previo de lentes de contacto blandos
E) Presencia de miodesopsias antes de la cirugía

PREGUNTA 44 6.02.1.003

**44. Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinopatía diabética
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 45 6.02.1.003

**45. Lactante de 7 meses cuya madre nota que al iluminar sus ojos con linterna, el ojo derecho refleja luz blanca (leucocoria) en vez del habitual reflejo rojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Descartar toxoplasmosis ocular: solicitar serología
B) Catarata congénita: derivar urgente a oftalmología
C) Retinoblastoma: derivar urgente a oftalmología
D) Retinopatía del prematuro: si no fue prematuro, tranquilizar
E) Glaucoma congénito: iniciar colirio

PREGUNTA 46 6.02.1.003

**46. Paciente con agudeza visual 20/40 bilateral que no mejora con agujero estenopeico. Refracción sin cambios. ¿Cuál es la causa más probable de esta alteración visual?**

A) Opacidad de medios (catarata u otra causa no refractiva)
B) Error refractivo no corregido
C) Ambliopía
D) Glaucoma
E) Degeneración macular

PREGUNTA 47 6.02.1.003

**47. En el enfrentamiento clínico sistemático de Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 48 6.02.2.003

**48. Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias: a. Desprendimiento de retina**

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

PREGUNTA 49 6.02.2.004

**49. Un hombre de 68 años con antecedentes de tabaquismo y cardiopatía hipertensiva consulta por pérdida total y súbita de la visión en su ojo derecho hace 1 hora mientras desayunaba. No refiere dolor, cefalea ni traumatismo. Al examen el ojo está blanco, la agudeza visual es de bultos a 50 cm y presenta defecto pupilar aferente relativo en ojo derecho. En el fondo de ojo destaca una retina blanquecina edematosa con una mancha rojo cereza a nivel foveal y vasos arteriales filiformes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Desprendimiento de retina regmatógeno total
B) Oclusión de la arteria central de la retina
C) Oclusión de la vena central de la retina
D) Hemorragia vítrea masiva
E) Neuritis óptica isquémica no arterítica

PREGUNTA 50 6.02.2.004

**50. Una mujer de 62 años hipertensa consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo izquierdo en las últimas 24 horas. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas masivas en llama en los cuatro cuadrantes, venas tortuosas muy dilatadas y exudados algodonosos. Tres meses después acude a urgencias por dolor ocular insoportable en el mismo ojo y ojo rojo intenso con PIO de 55 mmHg. ¿Qué complicación ha desarrollado?**

A) Glaucoma agudo por cierre angular primario
B) Glaucoma neovascular secundario a isquemia retiniana ("glaucoma de los 100 días")
C) Endoftalmitis endógena bacteriana
D) Desprendimiento de retina exudativo
E) Uveítis anterior hipertensiva secundaria a toxoplasmosis

PREGUNTA 51 6.02.1.031

**51. [ATENCIÓN PRIMARIA: Vicios de refracción en personas de 65 años o más · 6.02.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vicios de refracción en personas de 65 años o más. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 52 6.02.2.004

**52.** **Un joven de 18 años consulta por dificultad progresiva para ver con nitidez el pizarrón de la universidad, refiriendo que tiene que entrecerrar los ojos para enfocar a la distancia. Al examinarlo de cerca para leer un libro, su visión es perfecta y no refiere molestias. En la tabla de Snellen su agudeza visual de lejos es 20/60 bilateral, la cual mejora de inmediato a 20/20 al mirar a través de un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico refractivo y el tipo de lente corrector adecuado?**

A) Hipermetropía; corregir con lentes convergentes positivos (+)
B) Miopía; corregir con lentes divergentes negativos (-)
C) Presbicia precoz; corregir con lentes bifocales
D) Astigmatismo irregular; corregir con lentes prismáticos
E) Ambliopía anisometrópica; indicar parche oclusivo

PREGUNTA 53 6.02.2.004

**53.** **Un lactante de 10 meses es llevado a control por sospecha de estrabismo. Al examen, el oftalmólogo constata una catarata congénita monocular densa en el ojo derecho que ocluye completamente el eje pupilar. ¿Cuál es el principal riesgo a largo plazo si no se opera oportunamente antes del año de vida?**

A) Glaucoma neovascular de ángulo abierto
B) Ambliopía profunda por deprivación sensorial irreversible
C) Desprendimiento de retina traccional
D) Retinoblastoma bilateral secundario
E) Subluxación anterior del cristalino

PREGUNTA 54 6.02.2.004

**54.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

## BLOQUE 4 PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

PREGUNTA 55 6.02.1.025

**55.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores de conjuntiva · 6.02.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores de conjuntiva. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 6.02.2.009

**56.** **[URGENCIA: Parálisis III par + midriasis · 6.02.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Parálisis III par + midriasis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 57 6.02.1.022

**57.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Retinopatía del prematuro · 6.02.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retinopatía del prematuro. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 6.02.1.023

**58.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Retinopatía diabética · 6.02.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retinopatía diabética. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 6.02.1.027

**59.** **Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra completamente asintomático desde el punto de vista visual. ¿Cuál es la indicación correcta respecto al tamizaje oftalmológico según las guías clínicas del MINSAL y la garantía GES N° 23?**

A) Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente

B) Esperar 5 años desde el diagnóstico para realizar el primer fondo de ojo

C) Solicitar fondo de ojo únicamente si la hemoglobina glicosilada supera el 8.0%

D) Realizar fondo de ojo solo cuando el paciente refiera disminución de agudeza visual

E) Derivar a cirugía preventiva de catarata bilateral de inmediato

PREGUNTA 60 6.02.1.027

**60.** **¿Cuál es la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en los pacientes con diabetes mellitus?**

A) Glaucoma neovascular de ángulo cerrado

B) Edema macular diabético

C) Desprendimiento de retina regmatógeno

D) Oclusión de la arteria central de la retina

E) Neuritis óptica desmielinizante

PREGUNTA 61 6.02.1.027

**61.** **Un hombre de 60 años con diabetes mellitus mal controlada consulta por pérdida súbita, indolora y masiva de la visión en su ojo derecho ocurrida esta mañana. Refiere que ve todo "rojo oscuro y con telarañas flotantes". Al examen físico el ojo no está rojo ni duele, no hay reflejo rojo pupilar en el ojo derecho y a la oftalmoscopía es imposible visualizar los detalles de la retina debido a una opacidad hemática en la cavidad posterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorragia vítrea secundaria a retinopatía diabética proliferativa

B) Glaucoma agudo fulminante

C) Catarata hipermadura morgagniana

D) Endoftalmitis micótica endógena

E) Queratitis dendrítica extensa

PREGUNTA 62 6.02.1.027

**62.** **¿Cuál es el mecanismo de acción principal y el objetivo terapéutico de la panfotocoagulación con láser de argón en la retinopatía diabética proliferativa?**

A) Coagular directamente la arteria central de la retina para disminuir la presión vascular

B) Destruir zonas de retina periférica isquémica para reducir la producción de factores angiogénicos (VEGF) y lograr la regresión de los neovasos

C) Eliminar físicamente los exudados duros lipídicos de la fóvea

D) Aumentar la presión intraocular para aplanar la retina desprendida

E) Reemplazar el humor vítreo por humor acuoso artificial

PREGUNTA 63 6.02.1.027

**63.** **Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. ¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A) Grado I

B) Grado II

C) Grado III

D) Grado IV

E) Retinopatía proliferativa grado B

PREGUNTA 64 6.02.1.027

**64.** **Un hombre de 45 años ingresa al servicio de urgencias con presión arterial de 230/140 mmHg, cefalea holocraneana y confusión. Al fondo de ojo se evidencia borramiento de los bordes de ambas papilas ópticas con sobreelevación papilar, exudados algodonosos y hemorragias retinianas en llama. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al manejo de su presión arterial?**

A) Administrar nifedipino sublingual para descender la presión arterial a menos de 120/80 mmHg en 15 minutos

B) Hospitalizar en cuidados intensivos e iniciar labetalol endovenoso reduciendo la presión arterial media en un 20 a 25% en las primeras horas

C) Indicar enalapril oral 20 mg y enviar a domicilio con control en 48 horas

D) Realizar punción lumbar urgente antes de iniciar cualquier tratamiento hipotensor

E) Indicar diuréticos de asa orales en dosis única y analgesia

PREGUNTA 65 6.02.1.010

**65.** **Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación: Foto 14 (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733277 El diagnóstico más probable es:**

A) Desprendimiento de retina

B) Retinopatía hipertensiva

C) Trombosis de la vena central de la retina

D) Catarata

E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 66 6.02.1.020

**66. Una mujer de 72 años consulta porque nota que los marcos de las puertas y los azulejos de su baño se ven curvados y distorsionados al mirar con su ojo izquierdo. Al examen con la cartilla de cuadrícula de Amsler describe que las líneas rectas de la rejilla se ondulan hacia el centro de la mirada. El fondo de ojo revela drusas confluentes y una pequeña hemorragia subretiniana paramacular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la terapia de primera línea indicada?**

A) Desprendimiento de retina regmatógeno; fotocoagulación láser periférica
B) Degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda; inyecciones intravítreas de anti-VEGF
C) Retinopatía hipertensiva grado IV; nitroprusiato endovenoso
D) Neuritis óptica isquémica anterior; corticoides sistémicos
E) Glaucoma crónico simple; colirio de latanoprost nocturno

PREGUNTA 67 6.02.1.020

**67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la pérdida visual producida por la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es CORRECTA?**

A) Conduce a una pérdida concéntrica del campo visual periférico respetando la fóvea hasta el final
B) Causa un escotoma central que impide la lectura y reconocimiento de rostros, pero preserva la visión periférica de orientación
C) Produce ceguera total completa de ambos ojos impidiendo incluso la deambulación del paciente
D) Afecta de forma exclusiva a pacientes jóvenes miopes menores de 40 años
E) Cursa con dolor ocular severo y midriasis media fija arreactiva

PREGUNTA 68 6.02.1.001

**68. Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero estenopeico. No presenta do- lor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma
B) Estrabismo
C) Vicio de refracción
D) Catarata
E) Coriorretinitis

PREGUNTA 69 6.02.1.001

**69. Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2 y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una ACCIÓN ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en este paciente?**

A) Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva
B) Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa
C) Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular
D) Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología
E) Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

PREGUNTA 70 6.02.1.001

**70. Un paciente de 26 años recibe un golpe de puño directo en el ojo derecho durante una riña. Al examen en el box se aprecia un hipema traumático que ocupa el tercio inferior de la cámara anterior (Grado I), agudeza visual 20/40 y no hay signos de globo abierto. ¿Cuál es la indicación de manejo ambulatorio o en sala más adecuada y la complicación principal que se busca prevenir en los primeros días?**

A) Reposo en cama con cabecera a 45 grados, protector rígido y evitar aspirina/AINEs; prevenir resangrado a las 48-72 horas
B) Reposo en decúbito prono estricto con la cara hacia abajo; prevenir catarata traumática
C) Indicar aspirina 500 mg cada 8 horas para licuar el coágulo; prevenir la trombosis de arteria central
D) Realizar paracentesis corneal inmediata con aguja fina en el box de urgencias
E) Instilar colirio de pilocarpina cada 15 minutos; prevenir la ciclоplejía traumática

PREGUNTA 71 6.02.1.001

**71. Un tornero mecánico ingresa a urgencias tras sentir el impacto de una partícula de acero a alta velocidad en su ojo izquierdo mientras utilizaba una pulidora sin gafas protectoras. La agudeza visual es 20/30, se observa una mínima hemorragia subconjuntival temporal pero no se aprecian cuerpos extraños en la córnea ni fondos de saco. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección que debe solicitarse para descartar un cuerpo extraño intraocular radiopaco?**

A) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con cortes finos
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbita sin contraste con cortes finos de 1 mm
C) Radiografía simple de cráneo anteroposterior
D) Ecografía ocular modo A con sonda de alta frecuencia
E) Gammagrafía ósea facial

PREGUNTA 72 6.02.1.001

**72. ¿Cuál es el objetivo principal de administrar antieméticos parenterales (como ondansetrón endovenoso) en un paciente con sospecha de estallido o ruptura de globo ocular?**

A) Prevenir la absorción sistémica de las toxinas de la flora conjuntival
B) Evitar las náuseas y el vómito, ya que la maniobra de Valsalva asociada eleva bruscamente la presión intraocular y puede expulsar el contenido intraocular
C) Inducir miosis pupilar farmacológica para sellar la herida
D) Facilitar la penetración de los colirios a través de la barrera hematoencefálica
E) Disminuir la producción de humor acuoso por los procesos ciliares

PREGUNTA 73 6.02.1.028

**73.** **Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Chalazión crónico
B) Orzuelo interno
C) Carcinoma basocelular
D) Carcinoma espinocelular
E) Melanoma ocular

PREGUNTA 74 6.02.1.028

**74.** **Un paciente de 70 años consulta por aparición de una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace un año y que ha crecido al tamaño que se observa en la siguiente imagen (Fuente: https://hospitaluvrocio.es/): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Orzuelo
B) Chalazión
C) Melanoma
D) Carcinoma basocelular
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

PREGUNTA 75 6.02.2.001

**75.** **Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:**

A) Ungüento antibiótico y parche ocular
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Hielo local
D) Corticoides tópicos
E) Analgésicos

PREGUNTA 76 6.02.2.002

**76.** **Un trabajador de aseo sufre salpicadura accidental de soda cáustica líquida en ambos ojos. Es llevado de inmediato al centro de salud familiar más cercano. ¿Cuál es la primera medida que debe realizar el personal de salud al recibir al paciente en el establecimiento?**

A) Evaluar y registrar la agudeza visual con la tabla de Snellen
B) Instilar colirio de ácido acético diluido para neutralizar químicamente el álcali
C) Iniciar irrigación ocular continua profusa con suero fisiológico o agua corriente de forma inmediata
D) Aplicar ungüento oftálmico con corticoides y ocluir con parche estéril
E) Llamar a la ambulancia y esperar la llegada del médico oftalmólogo sin tocar los ojos

PREGUNTA 77 6.02.2.002

**77.** **¿Por qué las quemaduras oculares provocadas por álcalis (como la cal, amoníaco o soda cáustica) revisten una gravedad mucho mayor que las provocadas por ácidos fuertes?**

A) Porque los ácidos producen necrosis por coagulación que forma una barrera proteica protectora limitando su penetración, mientras que los álcalis producen necrosis por licuefacción con saponificación que favorece la penetración profunda continua
B) Porque los álcalis se evaporan instantáneamente destruyendo el cristalino por calor seco
C) Porque los ácidos tienen un pH neutro que no interactúa con las membranas celulares
D) Porque los álcalis provocan vasoconstricción retiniana mediada por receptores adrenérgicos
E) Porque las quemaduras por ácidos siempre se resuelven con lágrimas artificiales

PREGUNTA 78 6.02.1.030

**78.** **Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente: FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria).**

A) Uveítis anterior
B) Catarata
C) Disgenesia pupilar
D) Endoftalmitis
E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 79 6.02.1.030

**79.** **Un escolar de 9 años es evaluado en urgencias por edema y eritema palpebral izquierdo severo tras un cuadro catarral de una semana. Al examen físico presenta fiebre de 38.8 °C. La apertura palpebral espontánea está dificultada por el edema, pero al separar manualmente los párpados se constata que los movimientos oculares están completamente conservados y son indoloros, no hay proptosis y la agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Celulitis orbitaria postseptal; hospitalizar para drenaje quirúrgico inmediato por orbitotomía
B) Celulitis preseptal; iniciar tratamiento antibiótico oral ambulatorio con amoxicilina-ácido clavulánico y control en 24 horas
C) Trombosis del seno cavernoso; iniciar heparina endovenosa y trombolisis
D) Pseudotumor orbitario inflamatorio; indicar corticoides orales en megadosis
E) Conjuntivitis alérgica primaveral; prescribir colirio de antihistamínicos

PREGUNTA 80 6.02.1.030

**80.** **Una niña de 6 años hospitalizada por celulitis orbitaria derecha secundaria a sinusitis etmoidal presenta súbitamente cefalea intensa, náuseas, temperatura de 39.5 °C y comienza con hinchazón, enrojecimiento y proptosis marcada en el ojo izquierdo contralateral. Al examen neurológico se constata midriasis arreactiva bilateral y ptosis bilateral con imposibilidad total para mover ambos ojos en cualquier dirección (oftalmoplejía bilateral completa), con pérdida de sensibilidad en la frente. ¿Cuál es la complicación intracraneana más probable?**

A) Meningitis bacteriana aguda por neumococo sin foco trombótico
B) Trombosis séptica del seno cavernoso
C) Absceso epidural frontal contralateral aislado
D) Glaucoma agudo bilateral sincronizado
E) Encefalitis por virus herpes simple tipo 1

PREGUNTA 81 6.02.1.030

**81.** **¿Cuál es el estudio de imagen de primera línea indicado para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión anatómica y pesquisar complicaciones quirúrgicas ante la sospecha clínica fundada de celulitis orbitaria?**

A) Radiografía de senos paranasales en proyecciones de Waters y Caldwell
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbitas, senos paranasales y cerebro con contraste endovenoso
C) Ecografía ocular modo B transpalpebral
D) Resonancia magnética nuclear sin contraste
E) Gammagrafía con galio-67

PREGUNTA 82 6.02.1.030

**82.** **¿Cuál es el esquema antimicrobiano empírico endovenoso de primera línea más recomendado para el tratamiento intrahospitalario de la celulitis orbitaria bacteriana en pediatría?**

A) Amoxicilina oral en suspensión cada 8 horas
B) Ceftriaxona endovenosa combinada con vancomicina (o clindamicina)
C) Ciprofloxacino en colirio tópico exclusivo
D) Aciclovir endovenoso en monoterapia
E) Gentamicina intramuscular en dosis única

PREGUNTA 83 1.01.1.015

**83.** **Una mujer de 29 años previamente sana consulta por disminución de la visión en su ojo izquierdo de 48 horas de evolución, acompañada de dolor en la órbita que se intensifica al mover los ojos. Al examen se constata agudeza visual de 20/70 en ojo izquierdo y 20/20 en ojo derecho. En la prueba de la linterna oscilante, al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se contraen intensamente, pero al pasar el foco de luz al ojo izquierdo ambas pupilas se dilatan de forma paradójica. El fondo de ojo muestra papilas de bordes netos y retina transparente sin anomalías. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para evaluar la etiología y el pronóstico de esta paciente?**

A) Tomografía computarizada de encéfalo sin contraste
B) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio
C) Punción lumbar urgente con manometría de apertura
D) Potenciales evocados somatosensoriales periféricos
E) Biopsia de la arteria temporal superficial

PREGUNTA 84 1.01.1.015

**84.** **Un hombre de 38 años consulta por cefaleas matutinas pulsátiles que aumentan con la tos desde hace dos semanas y episodios breves de oscurecimiento de la visión de 2 a 3 segundos de duración al ponerse de pie. Al examen su agudeza visual es 20/20 en ambos ojos, las pupilas son isocóricas y fotorreactivas normales sin DPAR, pero al fondo de ojo se evidencia borramiento completo de los bordes papilares de forma bilateral, con hiperemia y elevación de ambas cabezas del nervio óptico. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de prioridad obligatoria?**

A) Realizar punción lumbar en el box para medir la presión de apertura de inmediato
B) Solicitar neuroimagen urgente (TAC o RM de cerebro) para descartar un proceso expansivo intracraneano antes de cualquier otra intervención
C) Iniciar colirio de timolol al 0.5% cada 12 horas
D) Indicar tratamiento con acetazolamida oral y enviar a control ambulatorio
E) Prescribir paracetamol y lentes de descanso para la astenopía

PREGUNTA 85 6.02.1.016

**85.** **Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probale?**

A) Desprendimiento de retina
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Trombosis de arteria central de la retina
D) Neuritis óptica
E) Absceso orbitario

PREGUNTA 86 6.02.1.016

**86.** **Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Discromatopsia
B) Retinitis pigmentosa
C) Coriorretinitis
D) Desprendimiento de retina
E) Neuritis óptica

PREGUNTA 87 6.02.1.017

**87.** **Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuritis óptica
B) Degeneración macular relacionada con la edad
C) Accidente vascular encefálico occipital
D) Edema macular
E) Neuropatía óptica isquémica

PREGUNTA 88 6.02.1.017

**88.** **Un paciente de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 8po 2 y revascularización coronaria hace 3 años, consulta porque hace pocas horas notó que, de forma súbita, dejó de ver su pierna derecha con el ojo derecho. Al examen Fsico presenta inspección ocular normal, agudeza visual 20/30 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, pupilas isocóricas con defecto pupilar aferente rela8vo, y en la campimetría por confrontación se observa hemianopsia inferior del ojo derecho. El diagnós8co más probable es:**

A) Neuri2s óp2ca isquémica
B) Infarto del lóbulo occipital
C) Desprendimiento de re2na
D) Glaucoma
E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 89 6.02.1.017

**89.** **Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma agudo
B) Glaucoma crónico terminal
C) Neuritis óptica
D) Neuropatía óptica isquémica
E) Desprendimiento de retina

PREGUNTA 90 6.02.1.026

**90.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores de la vía óptica · 6.02.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores de la vía óptica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 1** **Respuesta: E** Estrabismo

6.02.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 38). Evalúa el manejo clínico de Estrabismo según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 2** **Respuesta: A** Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)

6.02.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 156). Evalúa el manejo clínico de Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 3** **Respuesta: C**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

El cuadro clínico con cefalea ocular lancinante, náuseas, halos de colores, midriasis media fija, edema corneal en vidrio deslustrado y ojo pétreo a la palpación es patognomónico de un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado (cierre angular con PIO típicamente > 50-70 mmHg). Es una emergencia oftalmológica absoluta que requiere inicio inmediato de hipotensores oculares sistémicos y tópicos (manitol EV, acetazolamida oral, betabloqueador tópico como timolol) y derivación urgente para iridotomía láser. La atropina (A) está contraindicada porque dilata más la pupila y agrava el bloqueo. Perla. Midriasis media fija más dolor y ojo pétreo es siempre glaucoma agudo.

**PREGUNTA 4** **Respuesta: B**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

Se trata de un cuadro clásico de Ojo Rojo Superficial (conjuntivitis bacteriana o viral incipiente) sin signos de alarma: agudeza visual normal, inyección puramente periférica que respeta el limbo, pupilas normales y córnea transparente. La conducta correcta en APS es el manejo sintomático e higiénico con colirio antibiótico de amplio espectro (cloranfenicol tópico) y educación. Los corticoides (C) están contraindicados en APS sin lámpara de hendidura. No requiere derivación urgente (A) ni imágenes (D). Perla. Ojo rojo sin dolor, sin baja de visión y con pupilas normales se maneja en APS sin derivación.

**PREGUNTA 5** **Respuesta: A**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

La presencia de ojo rojo profundo (inyección ciliar/periquerática), dolor ocular, fotofobia, miosis hiporreactiva unilateral y antecedente de enfermedad reumatológica (espondiloartritis asociada a HLA-B27) es la presentación arquetípica de una Uveítis Anterior Aguda (iridociclitis). La miosis se produce por espasmo del esfínter pupilar y del músculo ciliar debido a la inflamación intraocular. El glaucoma agudo (B) cursa con midriasis media fija, no miosis. La queratitis (C) tendría tinción positiva con fluoresceína. Trampa. Confundir la miosis de la uveítis con la midriasis media del glaucoma agudo es un error que invierte el tratamiento.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: B**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

El cuadro corresponde a un Hiposfagma o hemorragia subconjuntival espontánea. Es una patología benigna y autolimitada, secundaria a la rotura de un capilar conjuntival frágil (frecuente tras tos, estornudo o maniobra de Valsalva nocturna). Dado que no hay dolor, la visión es normal y los reflejos pupilares están indemnes, la conducta es netamente expectante: educación, tranquilidad y control tensional si procede. Se reabsorbe espontáneamente en 1 a 2 semanas. No requiere gotas (B). Trampa. Indicar colirios antibióticos o hemostáticos en el hiposfagma es una conducta incorrecta que medicaliza un cuadro benigno.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A**

6.02.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

Síntomas crónicos de ojo seco (arenilla, lagrimeo reflejo, fotofobia) + artritis reumatoide (síndrome de Sjögren secundario) = queratoconjuntivitis sicca. Tratamiento: lágrimas artificiales.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: A**

6.02.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 1). Evalúa el manejo clínico de Herida penetrante o perforante ocular según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

6.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas**

Es una conjuntivitis bacteriana, que se complicó con una celulitis orbitaria o postseptal (por la quemosis). La alergia al CAF suele presentarse de otra forma y es muy rara.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: A**

6.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

**Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conjuntivitis no infecciosa" (6.02.1.007), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: A**

6.02.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conjuntivitis viral no complicada" (6.02.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: C**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis**

Era un herpes periocular.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: A**

6.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Chalazion" (6.02.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

6.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis**

Es una dacriocistitis aguda. Se trata con ATB orales

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

6.02.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Orzuelo no complicado" (6.02.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: E**

6.02.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)**

La clínica parece una conjuntivitis alérgica (antecedente de asma), pero no estaba en las alternativas. El antecedente de rosácea orienta mucho a blefaritis, sin embargo, falta la descripción del eritema y descamación palpebral y le sobra la secreción mucosa y mucopurulenta. La conjuntivitis bacteriana crónica (mayor a 4 semanas) clásicamente se asocia a otras alteraciones, como la blefaritis, y sí tiene secreción mucosa y purulenta, más el ojo rojo. No se describe el aumento de volumen de la dacriocistitis. Es una pregunta difícil y no queda completamente claro cuál es el diagnóstico, pero dejaremos como correcta la conjuntivitis crónica, por el tiempo de evolución, por el factor de riesgo y por la clínica compatible. Es una pregunta muy difícil.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

6.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Leucoma corneal" (6.02.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

6.02.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)**

Cuadro clásico

---

## BLOQUE 2 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A** **Hifema**

6.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hifema" (6.02.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: E** **Hemorragia vítrea**

6.02.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La pérdida del rojo pupilar orienta mucho a hemorragia vítrea

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: D**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas**

La sospecha clínica es una queraGGs o una erosión corneal. El uso de lentes de contacto podría ser la causa. Con la Gnción con fluoresceína se pueden ver mejor las úlceras y erosiones corneales. La genioscopía es úGl en la evaluación del glaucoma agudo.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas**

El blanqueamiento vascular completo tras la instilación de fenilefrina tópica al 2.5% certifica que la dilatación vascular se ubica exclusivamente en el plexo episcleral superficial, lo que define a la Episcleritis Simple. La ausencia de dolor severo y la conservación de la visión apoyan la benignidad del cuadro. La conducta en APS es sintomática (lágrimas artificiales, compresas frías o un AINE tópico) con resolución espontánea en 1 a 2 semanas. La escleritis (A) no se blanquearía y presentaría dolor intenso terebrante. Perla. Ojo rojo sectorial que blanquea con fenilefrina y no duele intensamente es episcleritis.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas**

El paciente presenta una escleritis nodular anterior en el contexto de una vasculitis necrotizante sistémica (Granulomatosis con Poliangeítis). La falta de blanqueamiento con fenilefrina confirma la inflamación de la vasculatura escleral profunda. La complicación más grave y temida de la escleritis no tratada es la necrosis y lisis del colágeno escleral, lo que produce adelgazamiento escleral severo (la esclera se vuelve traslúcida y se visualiza la coroides subyacente de color azul oscuro) con eventual perforación ocular y pérdida irrecuperable del ojo (escleromalacia perforante). Requiere tratamiento inmunosupresor sistémico agresivo inmediato. Trampa. Pensar que la escleritis solo causa molestias inflamatorias superficiales sin riesgo estructural del ojo es un error conceptual grave.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

El cuadro corresponde a un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado, cuya presentación con cefalea y vómitos con frecuencia lleva a errores diagnósticos confundiéndose con migraña o ACV. La presencia de edema corneal, midriasis media fija y ojo pétreo certifica la hipertensión ocular extrema. El manejo farmacológico inicial obligatorio para salvar la visión es la combinación de Manitol EV (agente osmótico que reduce el volumen vítreo), Acetazolamida oral (inhibidor de anhidrasa carbónica que frena la síntesis de humor acuoso) y colirio de Timolol al 0.5%. La atropina (C) dilata la pupila y sería nefasta. La pilocarpina en monoterapia (D) no funciona con presiones tan altas por isquemia del esfínter. Perla. El manitol EV y la acetazolamida son la piedra angular del rescate en el glaucoma agudo.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

La predisposición anatómica al cierre angular (cámara anterior estrecha, hipermetropía, configuración del iris) es simétrica y bilateral en prácticamente todos los pacientes. Un paciente que ha sufrido una crisis de glaucoma agudo en un ojo tiene más de un 50% de probabilidad de presentar un cuadro idéntico en el ojo adelfo en los próximos meses o años si no se interviene. Por esta razón, la norma internacional y de examen establece de forma mandatoria la realización de Iridotomía Periférica Profiláctica con láser YAG en el ojo contralateral asintomático. Trampa. Pensar que el ojo sano no debe tocarse es un error grave: debe protegerse siempre con láser profiláctico.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

La tropicamida es un fármaco anticolinérgico parasimpaticolítico que bloquea los receptores muscarínicos del esfínter pupilar, produciendo midriasis farmacológica activa. En un ojo con ángulo estrecho no operado, la dilatación pupilar aplasta la base del iris contra la malla trabecular periférica, precipitando un bloqueo pupilar completo e hiperpresión intraocular masiva (crisis de glaucoma agudo). Cualquier fármaco midriático o anticolinérgico está terminantemente contraindicado en ángulos estrechos no tratados. Perla. Todo midriático puede desencadenar un glaucoma agudo en ojos anatómicamente predispuestos.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: C**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

La pilocarpina es un agonista colinérgico directo que estimula la contracción del músculo esfínter de la pupila, provocando miosis pupilar intensa. Al contraerse el esfínter y achicarse la pupila, el tejido iridiano se estira y adelgaza mecánicamente, tironeando de la raíz del iris hacia el eje central y desimpactándola del ángulo camerular. Esto libera la malla trabecular y restaura el drenaje normal del humor acuoso. No inhibe la síntesis de acuoso (eso lo hace el timolol y la acetazolamida) ni deshidrata el vítreo (eso lo hace el manitol). Perla. La pilocarpina genera miosis y desobstruye físicamente el ángulo.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

6.02.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

Glaucoma Congénito: La epífora, megalocórnea y buftalmos sugieren glaucoma congénito. La prueba de fluoresceína con aclaramiento lento es compatible con dacriocistitis congénita y glaucoma congénito. El valor normal del aclaramiento de fluoresceína es menor a 5 minutos.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

6.02.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

Es un glaucoma congénito clásico.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

6.02.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida**

Es un glaucoma agudo clásico.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

**Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG**

El diagnóstico es Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto confirmado por la tríada de hipertensión ocular (> 21 mmHg), daño estructural en la papila óptica (excavación > 0.6 con muesca inferior) y defecto campimétrico concordante (escalón nasal). El tratamiento médico de primera línea avalado por guías internacionales y del MINSAL son los análogos de prostaglandinas tópicos (como latanoprost, bimatoprost o travoprost) administrados en 1 sola dosis nocturna. Tienen la mayor potencia hipotensora con mínimos efectos sistémicos y excelente adherencia. Los diuréticos orales (C) no se usan en tratamientos crónicos por sus efectos adversos metabólicos. La atropina (D) está contraindicada. Perla. Latanoprost nocturno es el fármaco de elección indiscutido en el glaucoma crónico.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

**Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG**

La naturaleza silente del glaucoma crónico de ángulo abierto radica en su patrón de destrucción axonal: las fibras del nervio óptico que primero se lesionan corresponden a las áreas periféricas de la retina (produciendo escotomas aislados y constricción progresiva concéntrica del campo visual), mientras que el haz papilomacular que provee la visión central de alta resolución permanece intacto hasta las fases terminales. El paciente continúa leyendo la línea de 20/20 en la tabla de Snellen sin advertir que su campo visual se ha reducido a un "tubo estrecho", consultando solo cuando el daño es masivo e irreversible. Trampa. Creer que una agudeza visual de 20/20 descarta glaucoma crónico es el error más frecuente en medicina general.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: C**

6.02.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG**

Glaucoma Crónico: Una presión ocular mayor a 20 mmHg se considera elevada. La excavación papilar mayor a 0.3 también sugiere glaucoma crónico o de ángulo abierto. La gonioscopía, que examina el ángulo de drenaje del ojo, suele mostrar un ángulo abierto en este tipo de glaucoma.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: C**

6.02.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG**

Es un glaucoma crónico clásico, tanto por la PIO mayor a 20, como por la excavación papilar mayor a 0,3.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

2.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación**

El uso prolongado o repetido de corticosteroides (tanto sistémicos como tópicos) es la causa farmacológica más frecuente y característica de catarata subcapsular posterior. Esta variedad se ubica en el eje óptico nodal posterior, por lo que produce una pérdida visual precoz y marcada que empeora con la miosis pupilar diurna (luz solar directa o lectura). La catarata nuclear (C) se asocia al envejecimiento senil clásico. La traumática (D) es monocular y en roseta. Perla. Paciente usuario crónico de corticoides con baja visual rápida tiene catarata subcapsular posterior.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

2.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación**

La técnica estándar de elección a nivel mundial y cubierta por la garantía GES N° 21 en Chile es la Facoemulsificación con Implante de Lente Intraocular (LIO). Mediante incisiones corneales milimétricas (2.2 mm), se realiza capsulorrexis circular anterior y una sonda de ultrasonido fragmenta y aspira el núcleo y la corteza cristaliniana opacificada, conservando íntegra la cápsula posterior para insertar en su interior una lente intraocular artificial plegable que restituye la refracción del ojo. La extracción intracapsular (A) está en desuso por su alta tasa de complicaciones. La iridotomía (C) es para glaucoma agudo. Perla. La técnica estándar de catarata es siempre facoemulsificación con implante de LIO.

---

## BLOQUE 3 GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: C** **Obstrucción completa de la vía lacrimal**

6.02.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una atresia lagrimal clásica. No tien buftalmo ni opacidad corneal, como para pensar en glaucoma congénito.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A** **Heridas de párpados**

6.02.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas de párpados" como urgencia clínica (6.02.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

Es una catarata clásica.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

La tríada clásica de fotopsias (tracción vitreorretiniana), miodesopsias agudas (sangrado o condensación vítrea) y defecto de campo visual progresivo en cortina en un paciente con miopía magna (factor de riesgo número uno) e indoloro es patognomónica de Desprendimiento de Retina Regmatógeno. La agudeza visual conservada (20/25) indica que la fóvea aún no se ha desprendido (mácula "on"), lo que constituye una emergencia quirúrgica de horas antes de que el líquido alcance el centro foveal y provoque daño irreversible. Requiere reposo absoluto y derivación quirúrgica urgente vía GES N° 22. Perla. Fotopsias más cortina negra en ojo blanco de paciente miope es desprendimiento de retina.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

El desprendimiento de retina regmatógeno exige de manera sine qua non la presencia de una rotura o desgarro en la retina neurosensorial (del griego rhegma), a través del cual el humor vítreo licuado penetra al espacio subretiniano separando la retina del epitelio pigmentario. En cambio, el desprendimiento traccional se origina por la formación de bandas o membranas fibróticas proliferativas en la cavidad vítrea (características de la retinopatía diabética proliferativa o traumatismos penetrantes) que tiran y levantan físicamente la retina hacia el centro del ojo sin que exista una rotura inicial. Trampa. Confundir el mecanismo del desgarro regmatógeno con la tracción proliferativa diabética altera radicalmente la estrategia quirúrgica.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

Cuando se diagnostica una rotura o desgarro retiniano sintomático de forma precoz ANTES de que el vítreo líquido haya levantado la retina (desgarro sin desprendimiento), el tratamiento de elección es la Fotocoagulación con Láser de Argón (o crioterapia). El láser produce una quemadura térmica controlada en 360 grados alrededor de los bordes del desgarro, originando una cicatriz coriorretiniana densa y firme en pocos días que sella el orificio y "suelda" la retina al epitelio pigmentario, evitando de forma altamente efectiva el desarrollo de un desprendimiento de retina completo. Perla. El desgarro precoz se sella con fotocoagulación láser profiláctica ambulatoria.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

El factor pronóstico determinante de la agudeza visual final tras una cirugía de desprendimiento de retina es el estado de la mácula y el tiempo de isquemia foveal. Si la mácula nunca se desprendió (mácula "on"), más del 90% de los pacientes conservan su agudeza visual preoperatoria. En cambio, si la mácula se desprende (mácula "off"), los conos foveales sufren apoptosis y pérdida irreversible de segmentos externos; si el desprendimiento foveal persiste por más de 7 a 10 días, la recuperación de la visión central fina es sumamente pobre aun cuando la retina se reaplique anatómicamente con éxito. Perla. El desprendimiento de mácula prolongado es el mayor predictor de mala agudeza visual final.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

Es una catarata clásica por la disminución de la AV y por la alteración del rojo pupilar (la opacidad como estrella es la catarata misma). La RD no tiene síntomas; el edema macular tiene disminución de la AV en pocos días y no altera el rojo pupilar. El glaucoma no afecta la AV, sino el campo visual y no afecta el rojo pupilar. La HV tiene aparición súbita y se pierde el rojo pupilar.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

Leucocoria (reflejo pupilar blanco) en lactante: principal diagnóstico a descartar es CATARATA CONGÉNITA y retinoblastoma. A los 7 meses sin antecedente de prematuridad, catarata congénita es lo más frecuente. Derivación urgente a oftalmología para tratamiento precoz (cirugía antes de los 10 semanas para evitar ambliopía).

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

El agujero estenopeico mejora la AV solo en errores refractivos. Si NO mejora, la causa es una opacidad de medios (catarata, opacidad corneal, vítreo) o patología retinal/neural. En adulto: pensar en catarata.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: A**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo, la conducta médica prioritaria es: El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

6.02.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 71). Evalúa el manejo clínico de Desprendimiento de retina según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

6.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central**

La mancha rojo cereza sobre una retina pálida y edematosa, asociada a pérdida súbita e indolora de la visión y defecto pupilar aferente relativo, es el hallazgo patognomónico clásico de la Oclusión de la Arteria Central de la Retina (OACR). La retina neurosensorial se infarta volviéndose opaca y blanca, mientras que la fóvea (que carece de células ganglionares y se nutre directamente de la coroides profunda sana) brilla con su color rojo natural. La oclusión venosa (C) mostraría hemorragias en llamarada generalizadas. El desprendimiento (A) mostraría retina gris levantada y móvil. Perla. Retina pálida más mancha rojo cereza es siempre oclusión de la arteria central de la retina.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

6.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central**

El cuadro inicial corresponde a una Oclusión de la Vena Central de la Retina (OVCR) de tipo isquémico ("imagen en tormenta retiniana"). La falta de perfusión tisular masiva estimula la producción masiva de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el cual difunde hacia el segmento anterior produciendo rubeosis iridis (neovasos en el iris) y neovascularización del ángulo camerular. Estos vasos anómalos forman una membrana fibrovascular que bloquea mecánicamente la malla trabecular, desencadenando una crisis hipertensiva ocular severa, refractaria y muy dolorosa conocida típicamente como Glaucoma Neovascular o "glaucoma de los 100 días" por su aparición característica alrededor de los 3 meses post-trombosis. Perla. Oclusión venosa de la retina más dolor y presión alta a los 3 meses es glaucoma neovascular.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

6.02.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vicios de refracción en personas de 65 años o más" (6.02.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños**

La mala visión lejana contrastada con una excelente visión cercana en un paciente joven es la definición clásica de Miopía. En este defecto, los rayos convergen por delante de la retina debido a un exceso de potencia dióptrica corneal o a un aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular. La mejoría inmediata a 20/20 con el agujero estenopeico confirma que la causa es puramente refractiva. La corrección óptica se realiza mediante lentes divergentes, cóncavos o de poder negativo (-), que desplazan el foco hacia atrás sobre la retina. La hipermetropía (A) afectaría la acomodación y lectura cercana. Perla. Miopía = mala visión de lejos corregida con lentes divergentes negativos (-).

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños**

Una opacidad densa del cristalino en los primeros meses de vida bloquea la llegada de estímulos lumínicos a la retina durante la fase crítica de neurogénesis y maduración sináptica visual en la corteza occipital. Esto genera una Ambliopía por Deprivación Sensorial, que constituye la forma más grave, destructiva y difícil de tratar de ambliopía. Si la catarata congénita no se opera en las primeras semanas o meses de vida y no se inicia terapia oclusiva inmediata, la corteza visual correspondiente a ese ojo se atrofia de forma permanente e irreversible, dejando al paciente con ceguera funcional de por vida en ese ojo. Perla. La catarata congénita debe operarse de inmediato para evitar la ambliopía irreversible.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños**

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños, la conducta médica prioritaria es: La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

## BLOQUE 4 PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Tumores de conjuntiva**

6.02.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores de conjuntiva" (6.02.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A** **Parálisis III par + midriasis**

6.02.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Parálisis III par + midriasis" como urgencia clínica (6.02.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retinopatía del prematuro" (6.02.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retinopatía diabética" (6.02.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

En la Diabetes Mellitus Tipo 2, la enfermedad suele tener un curso subclínico y asintomático de 5 a 7 años de evolución antes del diagnóstico clínico formal. Por lo tanto, hasta un 20% de los pacientes recién diagnosticados de DM2 ya presentan algún grado de retinopatía diabética al debut. La norma técnica del MINSAL y la ley GES N° 23 establecen que todo paciente con DM2 debe someterse a evaluación de fondo de ojo con pupila dilatada (o retinografía) al momento del diagnóstico, y posteriormente una vez al año de por vida. En cambio, en la DM1 el fondo de ojo se inicia a los 5 años del debut. Perla. En DM2 el fondo de ojo se pide de inmediato al diagnóstico; en DM1 a los 5 años.

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

El Edema Macular Diabético (EMD) es la complicación que con mayor frecuencia produce pérdida de la agudeza visual central en pacientes diabéticos. Puede presentarse en cualquier estadio de la retinopatía, incluso en etapas no proliferativas leves o moderadas, debido a la hiperpermeabilidad de los capilares perifoveales con acúmulo de líquido intrarretiniano en la mácula. Su tratamiento de primera línea avalado por la evidencia son los fármacos anti-VEGF intravítreos. La hemorragia vítrea y el desprendimiento traccional causan cegueras más severas, pero son mucho menos frecuentes que el edema macular. Perla. La causa N° 1 de baja visual en diabéticos es el edema macular.

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

La pérdida súbita e indolora de la visión con visión de "humo, telarañas o tinte rojizo" y ausencia de visualización del fondo de ojo por pérdida del reflejo rojo en un paciente con diabetes de larga data es la presentación clínica clásica de una Hemorragia Vítrea (hemovítreo). En diabéticos se debe a la rotura espontánea de los neovasos frágiles de la retina en el contexto de una Retinopatía Diabética Proliferativa no tratada. Requiere reposo semisentado, suspensión de antiagregantes si es seguro, ecografía ocular modo B para descartar desprendimiento traccional asociado y eventual vitrectomía pars plana si no se reabsorbe espontáneamente. Perla. Pérdida súbita visual indolora con visión rojiza y fondo de ojo borroso en diabético es hemorragia vítrea.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

**Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

La Panfotocoagulación Retiniana con Láser (PPR) consiste en aplicar cientos o miles de disparos de láser térmico en la retina periférica no funcionante, respetando el polo posterior y la mácula. Al destruir el tejido retiniano periférico hipóxico e isquémico, se reduce drásticamente el consumo metabólico de oxígeno de la retina externa y se apaga la sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Como consecuencia de la caída de los niveles de VEGF, los neovasos anómalos sufren involución y regresión cicatrizal, eliminando el riesgo de hemorragia vítrea catastrófica y desprendimiento traccional. Perla. El láser panretiniano destruye retina isquémica para frenar el VEGF y secar los neovasos.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La presencia de cruces arteriovenosos patológicos (como el signo de Gunn de ocultamiento o afilamiento venoso y el signo de Salus de deflexión en S) junto con esclerosis arteriolar (hilos de cobre o plata) sin la presencia de hemorragias retinianas, exudados ni edema de papila define de manera unívoca al Grado II de la clasificación de Keith-Wagener-Barker. El Grado I solo tiene estrechamiento arteriolar sin cruces marcados. El Grado III añade exudados y hemorragias en llama. El Grado IV suma edema de papila. Perla. Cruces arteriovenosos patológicos (Gunn/Salus) sin hemorragias = Grado II.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una Retinopatía Hipertensiva Grado IV (edema de papila bilateral), lo que diagnostica una Emergencia Hipertensiva (hipertensión maligna/encefalopatía hipertensiva). El manejo requiere ingreso inmediato a UCI/UTI y fármacos endovenosos titulables (como labetalol o nitroprusiato). La regla farmacológica de oro es que la reducción tensional debe ser controlada y gradual, disminuyendo la presión arterial media entre un 20% y un 25% durante las primeras 2 a 4 horas. Bajar la presión bruscamente (especialmente con fármacos incontrolables como nifedipino sublingual, A) colapsa el flujo sanguíneo cerebral y del nervio óptico, pudiendo provocar un infarto cerebral isquémico o ceguera iatrogénica. Trampa. Nifedipino sublingual o descensos bruscos de PA están prohibidos en emergencias hipertensivas.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: E**

**Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central**

6.02.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: B**

**Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central**

6.02.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

La metamorfopsia (percepción de líneas rectas como onduladas) con alteración central en la rejilla de Amsler en un paciente senil con hemorragia subretiniana macular y drusas es diagnóstica de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) en su variante Húmeda o Neovascular. La causa es una membrana neovascular coroidea anómala estimulada por VEGF que sangra bajo la fóvea. La terapia de primera línea de elección que ha revolucionado el pronóstico de esta enfermedad son las inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-VEGF (como ranibizumab o aflibercept), las cuales frenan la proliferación vascular y reabsorben el fluido foveal. Perla. Metamorfopsia en rejilla de Amsler en paciente mayor es degeneración macular húmeda.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

**Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central**

6.02.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

La degeneración macular asociada a la edad destruye selectivamente la mácula lútea y la fóvea central, las cuales son responsables de la visión foveal de alta resolución, la agudeza visual fina, la discriminación del color y la capacidad para leer o reconocer detalles faciales. Sin embargo, la retina periférica permanece indemne y funcionante, por lo que el paciente conserva su campo visual periférico (visión de orientación o navegación), lo que le permite caminar sin tropezar y ser autovalente en su desplazamiento. Nunca produce una ceguera total con pérdida de percepción de luz (amaurosis completa). Trampa. Creer que la DMAE deja al paciente completamente ciego de todo el campo visual es un error de concepto.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: C**

**Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La mejora de la AV al mirar por un agujero estenopeico es característico de los vi- cios de refracción.

**PREGUNTA 69** **Respuesta: C**

**Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta signos inequívocos de Globo Ocular Abierto (herida penetrante corneal con prolapso o herniación de tejido uveal/iris a través de la brecha y atalamia). En cualquier sospecha de globo abierto, realizar una tonometría (medición de la presión intraocular) está estrictamente contraindicado, ya que el contacto del tonómetro presiona el ojo y provoca la expulsión masiva del contenido intraocular (vítreo y retina), transformando una herida reparable en una pérdida ocular definitiva. Asimismo, están prohibidas las pomadas y los parches compresivos. La protección con concha rígida ósea (A), analgesia/antieméticos EV (B) y ayuno (D) son conductas mandatorias. Perla. En sospecha de herida penetrante ocular está terminantemente prohibido medir la presión o presionar el ojo.

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

**Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El manejo del hipema traumático consiste en reposo absoluto en cama con la cabecera elevada en 30 a 45 grados (para favorecer la sedimentación inferior de los glóbulos rojos por gravedad, liberando el eje pupilar y el trabéculo superior), protección ocular con concha rígida sin compresión, analgesia con paracetamol y colirio ciclopléjico. Están formalmente contraindicados el ácido acetilsalicílico y los AINEs porque alteran la hemostasia plaquetaria. La complicación más temida en los primeros 3 a 5 días es el RESANGRADO secundario a la lisis del coágulo primario, el cual suele ser mucho más extenso y desencadenar hipertensión ocular severa e impregnación hemática de la córnea. Trampa. La aspirina y AINEs están prohibidos en el hipema por riesgo de resangrado masivo.

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

**Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El método diagnóstico de elección indiscutido para la detección, localización espacial y evaluación de cuerpos extraños intraoculares (CEIO) es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas sin medio de contraste con cortes axiales y coronales finos (de 1 mm). La Resonancia Magnética (RM) está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA ante la sospecha de cualquier cuerpo extraño metálico o ferromagnético, ya que el potente campo magnético del resonador provocaría el movimiento o tracción violenta del fragmento dentro del ojo, causando laceraciones retinianas masivas, hemorragia vítrea catastrófica y pérdida inmediata del globo ocular. Perla. El TAC de órbita es el examen de elección para cuerpo extraño; la resonancia está prohibida.

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

**Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Durante el esfuerzo del vómito o las arcadas intensas, se genera una marcada maniobra de Valsalva con aumento abrupto de la presión intratorácica y de la presión venosa central. Esto se transmite instantáneamente al lecho coroideo vascular retrorbitario, provocando un pico masivo de presión intraocular. En un globo ocular con una solución de continuidad de espesor total (ojo abierto), este aumento de presión actúa como un émbolo hidrostático que extruye y expulsa hacia el exterior el iris, el cristalino, el humor vítreo e incluso la retina completa a través de la herida, transformando un ojo con pronóstico reparable en una lesión irrecuperable. Por ello, la analgesia y la antiemesis profiláctica son medidas de rescate de primer orden. Perla. El vómito en ojo abierto expulsa el vítreo: los antieméticos EV son obligatorios.

## BLOQUE 5 TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C** **Tumores de párpado**

6.02.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Carcinoma basocelular

**PREGUNTA 74** **Respuesta: D** **Tumores de párpado**

6.02.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Tumores de párpado.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso**

6.02.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La cauticación ocular se maneja con lavado con abundante agua o SF por 30 minutos. No confundir con las perforaciones oculares, que no se debe tocar el ojo ni aplicarle nada, sino solo analgésicos y antibióticos por vía endovenosa y derivación urgente.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: C**

6.02.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso**

En cualquier quemadura química ocular, el factor pronóstico determinante primordial de la sobrevida visual es el tiempo transcurrido hasta el inicio de la irrigación. La soda cáustica es un álcali fuerte que penetra activamente hacia las estructuras profundas del ojo en minutos mediante necrosis por licuefacción. El tratamiento debe iniciarse de forma inmediata en el mismo momento del ingreso del paciente, irrigando abundantemente con suero salino fisiológico o agua corriente a chorro durante al menos 20 a 30 minutos. Nunca debe perderse tiempo en tomar agudeza visual (A), llenar registros ni derivar sin lavar. Intentar neutralizar químicamente con ácidos (B) está formalmente contraindicado porque genera una reacción exotérmica con quemadura térmica adicional. Perla. Quemadura química = lavado ocular profuso inmediato antes de cualquier otra acción.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: A**

6.02.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso**

La diferencia fisiopatológica crucial radica en el tipo de necrosis tisular inducida. Los ácidos desnaturalizan y precipitan las proteínas celulares formando un coágulo o escara firme sobre la superficie corneal que actúa como un escudo o barrera mecánica que impide o retrasa la penetración del químico a planos más profundos. Por el contrario, los álcalis saponifican los lípidos de las membranas celulares, degradan los mucopolisacáridos del estroma corneal y producen necrosis por licuefacción. Esta lisis tisular no crea ninguna barrera de contención, permitiendo que los iones hidroxilo continúen penetrando activamente hacia el estroma profundo, la cámara anterior, el endotelio, el iris y el cristalino en cuestión de pocos minutos. Perla. Los álcalis licúan y penetran profundamente; los ácidos coagulan y se auto-limitan.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

6.02.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC**

Es una uveítis anterior clásica.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC**

La ausencia total de afectación de las estructuras intraorbitarias (motilidad ocular completamente libre e indolora, ausencia de proptosis y agudeza visual normal 20/20) confirma que el proceso infeccioso inflamatorio se encuentra estrictamente limitado por delante del tabique orbitario, lo que define a una Celulitis Preseptal (o periorbitaria). En pacientes estables y colaboradores, el tratamiento de elección es ambulatorio con antibióticos orales con cobertura frente a estafilococos y estreptococos (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo), indicando a los padres pautas estrictas de alarma y control clínico obligatorio en 24 horas. La celulitis orbitaria (A) tendría oftalmoplejía o proptosis. Perla. Movilidad ocular conservada e indolora descarta celulitis orbitaria y define celulitis preseptal.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC**

El seno cavernoso es una estructura venosa dural que recibe el drenaje de ambas órbitas a través de las venas oftálmicas y por el cual discurren los pares craneales III, IV, VI y las ramas V1 y V2 del trigémino. La extensión séptica de una celulitis orbitaria hacia el seno cavernoso produce la temible Trombosis del Seno Cavernoso. Sus signos patognomónicos cardinales son: 1) Bilateralización rápida del edema palpebral y proptosis al ojo opuesto (a través de los senos intercavernosos), 2) Oftalmoplejía dolorosa bilateral completa con ptosis (parálisis de pares III, IV y VI), 3) Hipoestesia en el territorio del nervio oftálmico (V1) y maxilar (V2), y 4) Compromiso sistémico grave y alteración de conciencia. Es una emergencia neuroquirúrgica de altísima mortalidad. Perla. La bilateralización de una celulitis orbitaria con oftalmoplejía total es trombosis del seno cavernoso.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC**

El examen imagenológico estándar de oro y de primera elección mandatorio ante cualquier sospecha de celulitis orbitaria es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas y senos paranasales con contraste endovenoso, extendida al encéfalo. El TAC permite: 1) Diferenciar fehacientemente la celulitis preseptal de la orbitaria, 2) Identificar la sinusitis paranasal de origen (etmoidal/maxilar), 3) Detectar precozmente colecciones purulentas que requieren drenaje quirúrgico urgente (absceso subperióstico y absceso intraorbitario), y 4) Descartar trombosis del seno cavernoso y empiemas intracraneanos. Las radiografías simples (A) están obsoletas por su baja sensibilidad. Perla. Sospecha de celulitis orbitaria exige TAC de órbita con contraste de urgencia.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC**

La celulitis orbitaria es una infección grave que pone en riesgo la visión y la vida, por lo que requiere hospitalización inmediata y antibioticoterapia parenteral de amplio espectro. La microbiología involucra patógenos nasosinusales como Streptococcus pneumoniae (incluyendo cepas con susceptibilidad intermedia a penicilinas), Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (incluyendo cepas meticilino-resistentes comunitarias SAMR-AC) y anaerobios orofaríngeos. El esquema estándar recomendado consiste en una cefalosporina de 3.ª generación parenteral con excelente penetración ósea y meníngea (Ceftriaxona o Cefotaxima) combinada con Vancomicina (o Clindamicina) para cobertura de SAMR y estreptococos. Los colirios (C) no tienen ninguna utilidad en infecciones orbitarias profundas. Perla. El tratamiento de la celulitis orbitaria es siempre endovenoso y hospitalizado con ceftriaxona más vancomicina.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

El cuadro corresponde a una Neuritis Óptica Retrobulbar desmielinizante en una mujer joven (pérdida visual monocular, dolor con la motilidad ocular, DPAR positivo y fondo de ojo normal). El examen de elección incuestionable es la Resonancia Magnética (RM) de cerebro y órbitas con contraste de gadolinio y secuencias FLAIR. La RM permite confirmar la inflamación y realce del nervio óptico y, de manera crucial, pesquisar la presencia de lesiones desmielinizantes asintomáticas en la sustancia blanca periventricular o cuerpo calloso, lo que define el riesgo de progresión a Esclerosis Múltiple clínicamente definida (bajo la cobertura del problema GES N° 68). La TAC (A) tiene muy baja resolución para lesiones desmielinizantes. Perla. Paciente joven con neuritis óptica monocular requiere RM cerebral con contraste para descartar esclerosis múltiple.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

El paciente presenta un Papiledema bilateral franco (edema de papila bilateral con agudeza visual conservada y oscurecimientos visuales posturales transitorios), lo que es un signo de alarma mayor de Hipertensión Endocraneana. La conducta médica primordial, obligatoria e impostergable es solicitar una Neuroimagen urgente (TAC o RM de encéfalo) para descartar la presencia de una masa expansiva intracraneana (tumor, hematoma, absceso) o hidrocefalia obstructiva. Está formalmente PROHIBIDO realizar una punción lumbar (A) a ciegas sin neuroimagen previa en un paciente con papiledema, ya que si existe una masa intracraneana la descompresión brusca del líquido cefalorraquídeo precipitará una herniación cerebral amigdalina o transtentorial fatal. Perla. Papiledema bilateral exige neuroimagen urgente para descartar masa cerebral antes de puncionar.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: D**

6.02.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

Tanto la clínica (amaurosis más defecto pupilar aferente o escape pupilar), como la esclerosis múltiple, orientan a Neuritis óptica. La causa más frecuente es autoinmune.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: E**

6.02.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

Es una neuritis óptica tanto por el antecedente de EM, como por la cínica, aunque tenía AV normal y no mencionaban el RFM.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: E**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

Tiene una amaurosis parcial súbita, lo que sugiere fuertemente una neuropatía óptica isquémica. Por ser la parte inferior del campo visual izquierdo lo afectado, probablemente la lesión se produjo en la parte superior del nervio óptico izquierdo. La neuritis óptica se instala en horas o días, la DMRE demora meses o años, el edema macular demora días y el accidente vascular occipital tiene una hemianopsia contralateral, afectado ambos campos visuales. Finalmente, también podría haber sido un desprendimiento de retina, aunque suele estar precedido por entopsias o fotopsias y avanzar lentamente, como una "caída de telón", "cierre de cortina" o "levantamiento de un muro".

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

Tanto por el inicio súbito, con factores de riesgo cardiovascular, como por el defecto pupilar aferente relativo (DPAR), es una neuropaVa óptica isquémica, con afectación de la zona superior del nervio óptico derecho (inerva la zona superior de la reGna y corresponde a la zona inferior del campo visual). El DPAR se ve también en la neuriGs óptica desmielinizante y en el desprendimiento de reGna extenso o en la oclusión de la arteria central de la reGna.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: D**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

6.02.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores de la vía óptica" (6.02.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 16 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 2

# DERMATOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Psoriasis, Cáncer de Piel & NET

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Dermatología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 16 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS** | | | | | |
| 6.01.1.001 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.002 | Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9, Q10, Q11 | Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7) |
| 6.01.1.003 | Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 16 · 16.3 (Pág. 9) |
| 6.01.1.008 | Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q17, Q18 | Tomo 16 · 16.4 (Pág. 11) |
| 6.01.1.011 | Fotodermatosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.026 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.028 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.032 | Vitiligo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.010 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 7.01.1.001 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8 | Tomo 16 · 16.1 (Pág. 5) |
| **BLOQUE 2: DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS** | | | | | |
| 6.01.1.004 | Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31, Q33, Q34 | Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9) |
| 6.01.1.005 | Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q32 | Tomo 16 · C.8 (Pág. 20) |
| 6.01.1.006 | Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27 | Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16) |
| 6.01.1.007 | Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.012 | Granuloma piogénico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q20 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.024 | Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.2.002 | Ántrax | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 16 · C.16 (Pág. 36) |
| 6.01.2.011 | Loxocelismo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q22, Q23 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS** | | | | | |
| 6.01.1.002 | Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q45, Q46 | Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7) |
| 6.01.1.015 | Líquen plano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.025 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.030 | Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q47 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.001 | Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.003 | Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43, Q44 | Tomo 16 · 16.10 (Pág. 33) |
| 6.01.2.004 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53 | Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29) |
| 6.01.2.006 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.012 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.013 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES** | | | | | |
| 1.09.1.006 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 6.01.1.009 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q64 | Tomo 16 · C.4 (Pág. 12) |
| 6.01.1.010 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.017 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.020 | Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.023 | Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.1.031 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.033 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q72 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.004 | Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q59, Q60, Q61, Q62 | Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29) |
| 6.01.2.005 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68 | Tomo 16 · 16.12 (Pág. 41) |
| 6.01.2.007 | Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q56 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.009 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.014 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q57 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.015 | Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS** | | | | | |
| 1.08.1.001 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 6.01.1.006 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86 | Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16) |
| 6.01.1.013 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q78 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.014 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.016 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.018 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.019 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q88 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.1.021 | **Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.022 | **Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.027 | **Sarna** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.029 | **Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q82 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.008 | **Completo** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.016 | **Completo** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.6.002 | **Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos** | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q83, Q84 | Tomo 16 · 16.15 (Pág. 52) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Dermatología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 16 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08.1.001 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q76, Q77 | Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5) |
| 1.09.1.006 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 6.01.1.001 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.002 | Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9, Q10, Q11, Q45, Q46 | Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7) |
| 6.01.1.003 | Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 16 · 16.3 (Pág. 9) |
| 6.01.1.004 | Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31, Q33, Q34 | Tomo 14 · 14.2 (Pág. 9) |
| 6.01.1.005 | Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q32 | Tomo 16 · C.8 (Pág. 20) |
| 6.01.1.006 | Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27, Q85, Q86 | Tomo 16 · 16.5 (Pág. 16) |
| 6.01.1.007 | Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.008 | Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q17, Q18 | Tomo 16 · 16.4 (Pág. 11) |
| 6.01.1.009 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q64 | Tomo 16 · C.4 (Pág. 12) |
| 6.01.1.010 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.011 | Fotodermatosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q1 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.012 | Granuloma piogénico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19, Q20 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.013 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q78 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.014 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q79 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.015 | Líquen plano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q37 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Completo** | | | |
| 6.01.1.016 | Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.017 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.018 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.019 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q88 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.020 | Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q58 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.021 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.022 | Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.023 | Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.024 | Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q28, Q29 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.025 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.026 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.027 | Sarna | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.028 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.029 | Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q82 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.030 | Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q47 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.031 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.1.032 | Vitiligo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q2 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Derivar** | | | |
| 6.01.1.033 | Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q72 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.001 | Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q48 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.002 | Ántrax | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 16 · C.16 (Pág. 36) |
| 6.01.2.003 | Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q40, Q41, Q42, Q43, Q44 | Tomo 16 · 16.10 (Pág. 33) |
| 6.01.2.004 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53, Q59, Q60, Q61, Q62 | Tomo 16 · 16.9 (Pág. 29) |
| 6.01.2.005 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68 | Tomo 16 · 16.12 (Pág. 41) |
| 6.01.2.006 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.007 | Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q56 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.008 | Completo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.009 | Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.010 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.011 | Loxocelismo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | — | Q22, Q23 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.012 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.013 | Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.014 | Inicial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q57 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.015 | Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.2.016 | Completo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8) |
| 6.01.6.002 | Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q83, Q84 | Tomo 16 · 16.15 (Pág. 52) |
| 7.01.1.001 | Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q7, Q8 | Tomo 16 · 16.1 (Pág. 5) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

PREGUNTA 1 6.01.1.011

**1. Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades in- feriores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a apare- cer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de an- dar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se mues- tran en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples le- siones eritemato-violáceas, muchas de ellas con disposición lineal) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fitodermatitis
B) Enfermedad ampollar
C) Urticaria solar
D) Lupus discoide
E) Vasculitis leucocitoclástica

PREGUNTA 2 6.01.1.032

**2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Vitiligo · 6.01.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vitiligo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 6.01.2.010

**3. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.010] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 4 6.01.1.001

**4. Un paciente de 17 años consulta por acné. Al examen Fsico se observan múl8ples comedones en cara, pecho y espalda, asociados a pápulas y pústulas abundantes, y presencia de algunos quistes en dichas zonas con cicatrices atróficas. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A) Peróxido de benzoilo tópico
B) Clindamicina tópica
C) Isotre2noína oral
D) Doxiciclina oral
E) Adapaleno tópico

PREGUNTA 5 6.01.1.026

**5. Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Acné del adulto
B) Rosácea
C) Dermatomiositis
D) Erupción polimorfa solar
E) Lupus cutáneo crónico

PREGUNTA 6 6.01.1.028

**6. Una paciente de 24 años presenta una cicatriz en la zona esternal de gran tamaño, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen Fsico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la cirugía inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Cicatriz hipertrófica en fase ac2va
B) Queloide
C) Cuerpo extraño
D) Úlcera de Marjolin
E) Granuloma piógeno

PREGUNTA 7 7.01.1.001

**7. Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de contenido líquido claro seroso, de 2 a 3 milímetros de diámetro, agrupadas en racimo sobre una base eritematosa en el labio superior. ¿Cuál es el nombre semiológico exacto de esta lesión elemental primaria?**

A) Pústula
B) Vesícula
C) Ampolla
D) Pápula
E) Erosión

PREGUNTA 8 7.01.1.001

**8. ¿Cuál es la diferencia semiológica e histológica fundamental entre una erosión y una úlcera cutánea?**

A) La erosión compromete solo la epidermis y cura sin dejar cicatriz, mientras que la úlcera compromete la dermis o hipodermis y cura dejando cicatriz
B) La erosión es siempre de origen infeccioso bacteriano y la úlcera es de origen autoinmune
C) La erosión es una lesión primaria y la úlcera es una lesión terciaria
D) La úlcera es indolora mientras que la erosión cursa con dolor lancinante
E) La erosión es mayor a 5 cm y la úlcera es menor a 1 cm

PREGUNTA 9 6.01.1.002

**9. Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico, se aprecia una zona sin cabellos, tal como se muestra en la foto: Foto 15 (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/XXXXXXX). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Lupus eritematoso cutáneo crónico
B) Alopecia areata
C) Alopecia androgénica
D) Tricotilomanía
E) Tiña capitis

PREGUNTA 10 6.01.1.002

**10. Un joven de 16 años presenta acné moderado con abundantes pápulas y pústulas en rostro y tercio superior del tórax. El médico decide iniciar tratamiento con un antibiótico tópico. ¿Cuál es el principio farmacológico obligatorio que debe respetarse para evitar la rápida aparición de cepas resistentes de Cutibacterium acnes?**

A) Prescribir clindamicina tópica en monoterapia por al menos 6 meses continuos
B) Combinar siempre el antibiótico tópico con peróxido de benzoilo o un retinoide tópico, evitando la monoterapia
C) Alternar ciprofloxacino tópico y vancomicina en días sucesivos
D) Usar dosis ultrabajas de penicilina tópica en crema
E) Indicar corticoide tópico de alta potencia junto con el antibiótico

PREGUNTA 11 6.01.1.002

**11. Una mujer de 22 años con acné nódulo-quístico severo y cicatrizal refractario a múltiples ciclos de doxiciclina oral es evaluada para inicio de isotretinoína oral. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un REQUISITO OBLIGATORIO ABSOLUTO antes y durante la prescripción de este medicamento?**

A) Demostrar niveles séricos indetectables de andrógenos suprarrenales
B) Doble método anticonceptivo eficaz, dos pruebas de embarazo negativas previas y monitorización mensual del perfil lipídico y pruebas hepáticas
C) Realizar biopsia cutánea previa de un nódulo activo
D) Indicar tratamiento concomitante con tetraciclinas orales a dosis altas
E) Dieta hipercalórica rica en grasas saturadas para favorecer la absorción

PREGUNTA 12 6.01.1.003

**12. Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. El diagnóstico más probable es:**

A) Carcinoma espinocelular
B) Carcinoma basocelular
C) Melanoma maligno
D) Granuloma piógeno
E) Queratosis actínica

PREGUNTA 13 6.01.1.003

**13. Una mujer de 44 años consulta por un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por enrojecimiento de mejillas y nariz que empeora al ingerir alimentos calientes o tras exponerse al sol. Al examen físico se constatan telangiectasias centrofaciales y múltiples pápulas y pústulas inflamatorias dispersas sobre ambas mejillas. No se observan comedones abiertos ni cerrados. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea más adecuado?**

A) Clobetasol crema al 0.05% cada 12 horas
B) Metronidazol en gel al 0.75% o ivermectina tópica al 1%
C) Adapaleno gel al 0.1% en monoterapia
D) Mupirocina ungüento al 2%
E) Ácido salicílico al 10% en solución alcohólica

PREGUNTA 14 6.01.1.003

**14. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico cutáneo permite DESCARTAR con mayor certeza el diagnóstico de rosácea y orientar definitivamente hacia acné vulgar?**

A) Presencia de eritema en la región malar
B) Presencia de comedones abiertos ("puntos negros") o cerrados
C) Presencia de pústulas foliculares confluentes
D) Presencia de telangiectasias centrofaciales
E) Empeoramiento de las lesiones con la ingesta de alcohol

PREGUNTA 15 6.01.1.003

**15. Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.). El diagnóstico más probable es:**

A) Carcinoma basocelular
B) Queratosis actínica
C) Queratosis seborreica
D) Granuloma piógeno
E) Melanoma acrómico

PREGUNTA 16 6.01.1.003

**16. Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Melanoma
B) Impétigo
C) Dermatitis de contacto
D) Quemadura solar
E) Carcinoma espinocelular

PREGUNTA 17 6.01.1.008

**17. Un hombre de 24 años consulta por caída progresiva de cabello en las regiones temporales y en la coronilla desde hace 2 años, con patrón idéntico al de su padre. Al examen se constata retroceso de la línea de implantación frontotemporal y adelgazamiento marcado del cabello en el vértex, observándose pelos muy finos y cortos junto a los orificios foliculares conservados. ¿Cuál es el fármaco oral de elección para frenar la progresión y su mecanismo de acción?**

A) Prednisona oral; inmunosupresión de linfocitos T periféricos
B) Finasteride oral; inhibición de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 disminuyendo la síntesis de dihidrotestosterona
C) Ketoconazol oral; inhibición de la síntesis de ergosterol
D) Espironolactona oral en dosis altas
E) Metotrexato oral semanal

PREGUNTA 18 6.01.1.008

**18. Una mujer de 30 años consulta muy angustiada porque desde hace 3 semanas se le cae el cabello en forma masiva cada vez que se peina o ducha, encontrando puñados de pelos en la almohada. Refiere que hace 3 meses dio a luz a su primer hijo por cesárea sin incidentes. Al examen físico no se aprecian placas alopécicas circunscritas; el cuero cabelludo es normal y la prueba de tracción ("pull test") es positiva difusa en toda la cabeza, desprendiéndose pelos con bulbo telógeno intacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Alopecia areata universal incipiente; hospitalizar para pulsos de metilprednisolona
B) Efluvio telógeno agudo puerperal; tranquilizar a la paciente y explicar que el cuadro es transitorio y se recuperará espontáneamente
C) Tiña del cuero cabelludo (Tinea capitis); indicar griseofulvina oral
D) Lupus discoide cutáneo; indicar biopsia en sacabocados urgente
E) Alopecia androgenética femenina severa; indicar finasteride oral inmediato

## BLOQUE 2 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

PREGUNTA 19 6.01.1.012

**19. Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía: Foto 4 (http://sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com/2013/03/no-todas-las-lesiones-de-la- XXXXXX.html) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

PREGUNTA 20 6.01.1.012

**20. Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pioderma gangrenoso
B) Hemangioma infantil
C) Nevo atípico inflamatorio
D) Granuloma telangiectásico
E) Melanoma maligno

PREGUNTA 21 6.01.2.002

**21. [URGENCIA: Ántrax · 6.01.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Ántrax. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 22 6.01.2.011

**22. Una paciente consulta por aparición de una lesión en el atebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico, se aprecia lo siguiente: FOTO (típica placa livedoide en el antebrazo).**

A) Loxsocelismo cutáneo
B) Necrosis grasa
C) Ectima
D) Pioderma gangrenoso
E) Fasceítis necrotizante

PREGUNTA 23 6.01.2.011

**23. Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?**

A) Latrodectus mactans (araña del trigo)
B) Paederus irritans (bicho candela)
C) Miasis cutánea
D) Loxosceles laeta (araña de rincón)
E) Picadura de abeja con reacción local

PREGUNTA 24 6.01.1.006

**24. Un hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas bien controlada sufre una herida cortante lineal en el antebrazo izquierdo durante un trabajo de carpintería. Tres semanas después, observa con sorpresa que sobre la cicatriz lineal de la herida se ha desarrollado una placa eritematosa idéntica a sus lesiones de psoriasis, cubierta de escamas plateadas nacaradas. ¿Cómo se denomina este fenómeno semiológico?**

A) Signo de Darier
B) Fenómeno isomórfico de Koebner
C) Signo de Nikolsky
D) Fenómeno de patergia
E) Signo de Auspitz

PREGUNTA 25 6.01.1.006

**25. Un escolar de 10 años, que presentó una faringoamigdalitis purulenta tratada con paracetamol hace dos semanas, es traído por su madre por la aparición súbita y eruptiva de múltiples pápulas eritematosas pequeñas de 3 a 5 mm, cubiertas por una fina escama blanquecina, diseminadas en todo el tronco y raíz de extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pitiriasis rosada de Gibert
B) Psoriasis en gotas (guttata)
C) Exantema súbito por herpesvirus 6
D) Sífilis secundaria (roseola sifilítica)
E) Escabiosis complicada

PREGUNTA 26 6.01.1.006

**26. ¿Cuál de los siguientes tratamientos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un paciente con psoriasis vulgar debido al altísimo riesgo de desencadenar un rebote potencialmente mortal hacia psoriasis pustulosa generalizada o eritrodermia al suspenderlo?**

A) Calcipotriol tópico en ungüento
B) Corticoides orales o sistémicos (como prednisona o betametasona parenteral)
C) Metotrexato oral semanal con suplemento de ácido fólico
D) Fototerapia con radiación ultravioleta B de banda estrecha
E) Anticuerpos monoclonales anti-interleucina 17 (secukinumab)

PREGUNTA 27 6.01.1.006

**27. Un hombre de 45 años con psoriasis en placas severa que compromete el 25% de su superficie corporal consulta además por dolor e inflamación tumefacta marcada en el segundo dedo de la mano derecha y en el tercer dedo del pie izquierdo, los cuales lucen completamente engrosados y tumefactos en toda su longitud, semejando un embutido. El factor reumatoide es negativo y la radiografía muestra erosiones en las articulaciones interfalángicas distales. ¿Cómo se denomina este signo inflamatorio característico?**

A) Nódulos de Heberden
B) Dactilitis o "dedo en salchicha"
C) Tofos gotosos periarticulares
D) Tenosinovitis infecciosa flexora
E) Eritema nudoso digital

PREGUNTA 28 6.01.1.024

**28. Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo. Compromete el 10% de la superficie corporal. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Psoriasis en placas
B) Dermatitis atópica
C) Dermatitis de contacto
D) Liquen plano
E) Micosis fungoide

PREGUNTA 29 6.01.1.024

**29.** **Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:**

A) Dermatittis de contacto
B) Psoriasis vulgar
C) Tiña corporis
D) Pitiriasis rosada de Gibert
E) Dermatitis atópica

PREGUNTA 30 6.01.1.004

**30.** **Un lactante de 8 meses presenta lesiones eccematosas eritematosas, exudativas y muy pruriginosas en ambas mejillas y caras de extensión de los miembros inferiores desde hace 2 meses. Al retirar el pañal, la piel de la zona genitoinguinal y perianal se encuentra perfectamente íntegra y sin eritema ni descamación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Dermatitis del pañal candidiásica
B) Dermatitis atópica del lactante
C) Psoriasis vulgar infantil
D) Dermatitis seborreica del lactante
E) Acrodermatitis enteropática

PREGUNTA 31 6.01.1.004

**31.** **Un niño de 5 años con antecedentes de dermatitis atópica severa presenta bruscamente un empeoramiento clínico con fiebre de 38.9 °C, malestar general y la aparición de múltiples vesículas umbilicadas agrupadas y pústulas dolorosas que rápidamente se erosionan formando costras en sacabocados sobre las áreas de eccema en cuello y flexuras. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación y el tratamiento específico de urgencia?**

A) Impétigo ampollar; indicar cefadroxilo oral
B) Eccema herpético de Kaposi (erupción variceliforme); hospitalizar e iniciar aciclovir endovenoso
C) Sepsis por Pseudomonas; iniciar ceftazidima endovenosa
D) Reacción adversa a corticoides tópicos; suspender todo tratamiento y observar
E) Molusco contagioso diseminado; realizar curetaje de las lesiones

PREGUNTA 32 6.01.1.005

**32.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Dermatitis del pañal · 6.01.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Dermatitis del pañal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 33 6.01.1.004

**33.** **Un trabajador de la construcción de 40 años consulta por eccema subagudo en ambas manos de 2 meses de evolución. Trabaja preparando mezclas de cemento y albañilería. Refiere prurito intenso que se extiende desde las palmas hacia el dorso de las manos y antebrazos. Se sospecha una dermatitis de contacto alérgica ocupacional. ¿Cuál es el alérgeno presente en el cemento más probablemente responsable del cuadro y el examen para confirmarlo?**

A) Níquel; determinación de IgE específica sérica
B) Dicromato de potasio (cromo); pruebas epicutáneas del parche (Patch test)
C) Látex; prueba de provocación bronquial
D) Resina epoxi; biopsia cutánea por congelación
E) Formaldehído; frotis directo con hidróxido de potasio

PREGUNTA 34 6.01.1.004

**34.** **Un hombre de 34 años consulta por eritema marcado y descamación grasosa amarillenta muy abundante que compromete de forma simétrica los surcos nasogenianos, el entrecejo y las regiones malares, con brotes intensos en el cuero cabelludo desde hace 3 meses, resistente a cremas hidratantes. Se observa además adelgazamiento moderado y una candidiasis oral al examen bucal. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de mayor prioridad clínica que debe plantear el médico?**

A) Solicitar perfil lipídico y curva de tolerancia a la glucosa para descartar síndrome metabólico
B) Solicitar prueba de ELISA para VIH con consentimiento informado
C) Realizar biopsia de cuero cabelludo para descartar lupus discoide
D) Indicar tratamiento con isotretinoína oral a dosis plenas
E) Prescribir antibióticos orales de amplio espectro por 6 meses

PREGUNTA 35 6.01.1.007

**35.** **Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:**

A) Celulitis
B) Erisipela
C) Dermatitis de contacto alérgica
D) Dermatitis de contacto irritativa
E) Piodermitis superficial

PREGUNTA 36 6.01.1.007

**36.** **Un paciente de 83 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, institucionalizado, presenta lesiones en las piernas, de 4 meses de evolución, que se muestran a continuación (www.mdsaude.com): ¿Cuál es el la conducta más adecuada?**

A) Mupirocina tópica
B) Flucloxacilina oral
C) Vendas elásticas
D) Biopsiar las lesiones
E) Vaselina más betametasona tópica

## BLOQUE 3 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

PREGUNTA 37 6.01.1.015

**37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Líquen plano · 6.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Líquen plano. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 6.01.2.006

**38. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.006] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 6.01.2.012

**39. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 40 6.01.2.003

**40. Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. ¿Cuál es la conducta de elección?**

A) Indicar mupirocina tópica

B) Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas

C) Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada

D) Indicar amoxicilina oral por 7 días

E) Indicar cefadroxilo oral por 7 días

PREGUNTA 41 6.01.2.003

**41. Un hombre de 55 años inició tratamiento con alopurinol 300 mg/día hace un mes por gota tofácea. Consulta por fiebre de 39 °C, malestar general y un exantema eritematoso difuso confluente en tronco y extremidades, acompañado de evidente edema periorbitario y en mejillas. Al examen no se observan ampollas ni desprendimiento cutáneo. En el hemograma destaca leucocitosis de 16.000/uL con 2.100 eosinófilos/uL y linfocitos atípicos. El perfil hepático muestra GOT 280 U/L y GPT 340 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson

B) Síndrome DRESS

C) Psoriasis eritrodérmica

D) Urticaria aguda alérgica

E) Enfermedad del suero

PREGUNTA 42 6.01.2.003

**42. ¿Cuál es el período de latencia típico característico que transcurre entre el inicio del medicamento causal y la aparición de las manifestaciones clínicas del Síndrome DRESS?**

A) Menos de 24 a 48 horas
B) De 3 a 5 días
C) De 2 a 8 semanas
D) De 6 a 12 meses
E) Más de 2 años de uso ininterrumpido

PREGUNTA 43 6.01.2.003

**43. ¿Cuál es el órgano interno que se compromete con mayor frecuencia en los pacientes con Síndrome DRESS y cuya afectación condiciona la principal causa de mortalidad?**

A) Riñón (glomerulonefritis membranosa)
B) Hígado (hepatitis tóxica / necrosis hepática)
C) Pulmón (derrame pleural hemorrágico)
D) Páncreas (pancreatitis aguda necrotizante)
E) Sistema nervioso central (meningoencefalitis aséptica)

PREGUNTA 44 6.01.2.003

**44. Una mujer de 32 años es diagnosticada de Síndrome DRESS secundario a fenitoína con compromiso hepático moderado (GPT 380 U/L). Se suspende el fármaco culpable y se inicia prednisona oral a 1 mg/kg/día con excelente mejoría clínica y paraclínica a las dos semanas. Respecto al plan de retiro de la corticoterapia, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender de inmediato la prednisona ya que los exámenes se han normalizado
B) Reducir la dosis rápidamente para suspenderla en un plazo de 3 a 5 días
C) Disminuir la dosis de prednisona de manera muy lenta y progresiva a lo largo de 2 a 3 meses
D) Mantener la dosis plena de 1 mg/kg/día de por vida para evitar reactivación de la epilepsia
E) Cambiar a hidrocortisona tópica en crema y suspender la vía oral

PREGUNTA 45 6.01.1.002

**45. Un hombre de 28 años presenta ronchas eritematosas pruriginosas diseminadas en el cuerpo desde hace 2 meses. El médico sospecha una urticaria crónica espontánea. Para corroborar el diagnóstico clínico antes de solicitar exámenes, ¿cuál es la pregunta semiológica clave que debe formularse respecto a las lesiones?**

A) ¿Cada roncha individual dura más de 72 horas en el mismo sitio?
B) ¿Las ronchas desaparecen en menos de 24 horas sin dejar marca, apareciendo otras en sitios distintos?
C) ¿Las lesiones dejan cicatrices atróficas deprimidas al desaparecer?
D) ¿Aparecen ampollas de contenido purulento en el centro de las ronchas?
E) ¿Las ronchas duelen intensamente al tacto sin producir picazón?

PREGUNTA 46 6.01.1.002

**46. Una paciente de 35 años con diagnóstico de urticaria crónica espontánea continúa presentando brotes diarios de habones intensamente pruriginosos a pesar de tomar religiosamente cetirizina 10 mg al día durante el último mes. No tiene signos de angioedema ni compromiso respiratorio. Según las guías internacionales de manejo de urticaria, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico recomendado?**

A) Iniciar prednisona oral 40 mg al día durante 3 meses continuos
B) Aumentar la dosis del antihistamínico H1 de segunda generación hasta cuatro veces la dosis estándar (cetirizina hasta 40 mg/día)
C) Cambiar a clorfenamina oral 4 mg cada 6 horas
D) Iniciar tratamiento con azatioprina oral
E) Indicar plasmaféresis de urgencia

PREGUNTA 47 6.01.1.030

**47. Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48h de evolución, prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A) Levocetirizina oral
B) Adrenalina subcutánea
C) Metilprednisolona EV
D) Omalizumab subcutáneo
E) Inmunoterapia sublingual

PREGUNTA 48 6.01.2.001

**48. [URGENCIA: Angioedema de Quinque · 6.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Angioedema de Quinque. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 49 6.01.1.025

**49.** **Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. La inspección facial muestra lo siguiente (fuente: prontopele.com.br): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

PREGUNTA 50 6.01.2.004

**50.** **Una mujer de 38 años consulta en urgencias por un cuadro febril de 48 horas de evolución acompañado de odinofagia intensa y ardor ocular. Al examen físico presenta lesiones eritematosas en diana atípica en tronco, con flictenas y desprendimiento de la piel que compromete aproximadamente el 7% de la superficie corporal total, asociado a úlceras orales con costras hemáticas labiales y conjuntivitis bilateral. Al realizar una suave presión tangencial con el dedo sobre la piel eritematosa, la epidermis se desliza y desprende. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el signo semiológico descrito?**

A) Eritema multiforme menor y Signo de Darier
B) Síndrome de Stevens-Johnson y Signo de Nikolsky
C) Necrólisis epidérmica tóxica y Fenómeno de Koebner
D) Penfigoide ampollar y Signo de Auspitz
E) Síndrome DRESS y Fenómeno de Patergia

PREGUNTA 51 6.01.2.004

**51.** **¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida que define y distingue formalmente a la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) del Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)?**

A) Mayor al 5% de superficie corporal total
B) Mayor al 10% de superficie corporal total
C) Mayor al 20% de superficie corporal total
D) Mayor al 30% de superficie corporal total
E) Mayor al 50% de superficie corporal total

PREGUNTA 52 6.01.2.004

**52.** **Un hombre de 62 años es hospitalizado por una Necrólisis Epidérmica Tóxica que compromete el 45% de la superficie corporal tras iniciar carbamazepina hace dos semanas. Al ingreso a la unidad de pacientes críticos se calculan los parámetros de la escala pronóstica SCORTEN. ¿Cuál de los siguientes hallazgos aporta UN PUNTO de gravedad en dicha escala?**

A) Frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto
B) Edad de 35 años
C) Bicarbonato sérico de 16 mEq/L
D) Glicemia en ayunas de 140 mg/dL
E) Nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 15 mg/dL

PREGUNTA 53 6.01.2.004

**53.** **En el manejo hospitalario de un paciente diagnosticado con Necrólisis Epidérmica Tóxica severa en un Centro de Quemados, ¿cuál de las siguientes intervenciones representa una MALA PRÁCTICA contraindicada?**

A) Mantener la temperatura ambiental de la sala entre 30 °C y 32 °C
B) Desbridamiento quirúrgico agresivo en pabellón de toda la epidermis desprendida y flictenas
C) Instilación frecuente de lágrimas artificiales sin preservantes y evaluación diaria por oftalmología
D) Reposición hídrica intravenosa guiada por diuresis horaria estricta
E) Suspensión inmediata de todos los fármacos no vitales introducidos en las semanas previas

PREGUNTA 54 6.01.2.013

**54.** **Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:**

A) Psoriasis eritrodérmica
B) Escarlatina quirúrgica
C) Pustulosis exantemática
D) Necrosis epidermolítica tóxica
E) Pénfigo

## BLOQUE 4 FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

PREGUNTA 55 6.01.1.023

**55.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos · 6.01.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 6.01.2.007

**56. [URGENCIA: Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido · 6.01.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 57 6.01.2.014

**57. [URGENCIA: Inicial · 6.01.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Inicial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 58 6.01.1.020

**58. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pénfigo · 6.01.1.020] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pénfigo. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 6.01.2.004

**59. Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas dos semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, ingles y caras internas de muslos. Al examen físico se aprecian numerosas ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas, muy tensas y duras a la palpación, asentadas sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana perilesional, la epidermis no se despega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pénfigo vulgar
B) Penfigoide ampollar
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Dermatitis herpetiforme
E) Epidermólisis bullosa simple

PREGUNTA 60 6.01.2.004

**60. ¿Cuál es el hallazgo anatomopatológico característico en la biopsia cutánea que define la ampolla del Pénfigo Vulgar?**

A) Ampolla subepidérmica con neutrófilos en las papilas dérmicas
B) Ampolla intraepidérmica suprabasal con acantolisis celular
C) Ampolla subcórnea con pústulas de espongiosis eosinofílica
D) Necrosis de espesor total de la epidermis con despegamiento dermoepidérmico
E) Vacuolización de la capa basal con infiltrado linfocítico en banda

PREGUNTA 61 6.01.2.004

**61. Una paciente de 50 años con diagnóstico confirmado de Pénfigo Vulgar extenso inicia tratamiento de inducción. ¿Cuál es el tratamiento médico de primera línea indicado para controlar la actividad de la enfermedad?**

A) Corticoides sistémicos a dosis altas (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)
B) Antihistamínicos H1 orales de segunda generación en dosis estándar
C) Dapsona oral combinada con dieta estricta libre de gluten
D) Aciclovir oral en dosis de 800 mg cinco veces al día
E) Metotrexato subcutáneo a dosis bajas en monoterapia exclusiva

PREGUNTA 62 6.01.2.004

**62. ¿Cuál es el patrón característico observado en la Inmunofluorescencia Directa (IFD) de una biopsia perilesional en un paciente con Penfigoide Ampollar?**

A) Depósito de IgA granular en los vértices de las papilas dérmicas
B) Depósito intercelular intraepidérmico de IgG en patrón de red de pescar
C) Depósito lineal y continuo de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal
D) Ausencia total de depósitos inmunes en la epidermis y dermis
E) Depósito granular de IgM en los vasos capilares dérmicos superficiales

PREGUNTA 63 6.01.2.015

**63. [URGENCIA: Pénfigo y penfigoide · 6.01.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pénfigo y penfigoide. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 64 6.01.1.009

**64. [ATENCIÓN PRIMARIA: Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin · 6.01.1.009] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 65 6.01.1.010

**65. [ATENCIÓN PRIMARIA: Eritema polimorfo menor · 6.01.1.010] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Eritema polimorfo menor. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 66 6.01.1.031

**66. Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Queratosis seborreica

B) Melanoma

C) Panadizo

D) Verruga vulgar

E) Cuerpo extraño periungueal

PREGUNTA 67 6.01.2.005

**67. Un adulto joven de 24 años consulta por una erupción cutánea en el dorso de ambas manos y antebrazos caracterizada por lesiones redondeadas eritematosas, con un centro purpúrico violáceo rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo eritematoso externo (lesiones en diana de 3 anillos). Refiere haber tenido un episodio de herpes labial hace una semana. Al examen físico no se palpan adenopatías y el signo de Nikolsky es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal más frecuentemente asociado?**

A) Síndrome de Stevens-Johnson por ingesta de paracetamol

B) Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple

C) Urticaria multiforme por virus de Epstein-Barr

D) Penfigoide ampollar por exposición a radiación UV

E) Lupus eritematoso discoide por fotosensibilidad

PREGUNTA 68 6.01.2.005

**68.** **Un paciente de 28 años presenta su quinto episodio en el último año de eritema multiforme con lesiones típicas en diana en manos y antebrazos, todos ellos precedidos 10 días antes por un brote visible de herpes labial recurrente. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada para prevenir futuros episodios?**

A) Prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día de forma indefinida
B) Tratamiento profiláctico continuo con Aciclovir oral durante 6 meses
C) Aplicación de protector solar factor 50+ como única medida
D) Inmunoterapia con interferón gamma recombinante subcutáneo
E) Derivación para plasmaféresis de mantención mensual

PREGUNTA 69 6.01.2.009

**69.** **Adulto mayor con dolor en cuero cabelludo seguido de vesículas en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Aciclovir tópico 5% en crema
B) Famciclovir 500 mg cada 8 horas por 7 días
C) Prednisona oral 40 mg/día por 5 días
D) Gabapentina 300 mg cada 8 horas
E) Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

PREGUNTA 70 1.09.1.006

**70.** **Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A) Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta
B) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo
C) Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética
D) Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión
E) Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

PREGUNTA 71 6.01.1.017

**71.** **Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente: Fuente: www.alamy.com El diagnóstico más probable es:**

A) Nevo
B) Melanoma
C) Léntigo
D) Queratosis seborreica
E) Queratosis actínica

PREGUNTA 72 6.01.1.033

**72.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Vasculitis cutáneas · 6.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vasculitis cutáneas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

## BLOQUE 5 ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

PREGUNTA 73 6.01.1.027

**73.** **Un paciente de 35 años consulta por intenso prurito en la zona genital de una semana de evolución. Al examen físico, se observan lesiones escrotales, que se muestran en la imagen (fuente: https://rafalafena.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/03/....). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Prúrigo nodular
B) Infección por virus papiloma humano
C) Sífilis primaria
D) Escabiosis
E) Sífilis secundaria

PREGUNTA 74 6.01.2.008

**74.** **[URGENCIA: Completo · 6.01.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Completo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 6.01.2.016

**75. [URGENCIA: Completo · 6.01.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Completo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 76 1.08.1.001

**76. Un hombre de 68 años presenta en la punta nasal una lesión papular de 6 mm de diámetro, de coloración blanquecina perlada translúcida, de bordes redondeados solevantados, con presencia de finas telangiectasias en su superficie y una úlcera milimétrica en el centro. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

A) Carcinoma basocelular nódulo-ulcerativo
B) Carcinoma espinocelular queratoacantoma
C) Melanoma amelanótico de extensión superficial
D) Queratosis seborreica irritada
E) Lupus eritematoso discoide crónico

PREGUNTA 77 1.08.1.001

**77. Una mujer de 72 años consulta por una lesión en el labio inferior que no cicatriza desde hace 6 meses. Al examen se observa una placa de 12 mm, de base indurada e infiltrada, con superficie ulcerada y cubierta de costra hiperqueratósica amarillenta adherente, que sangra al desprendimiento. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?**

A) Carcinoma basocelular superficial
B) Carcinoma espinocelular infiltrante
C) Herpes labial recidivante crónico
D) Aftosis oral recurrente mayor de Sutton
E) Queilitis angular bacteriana

PREGUNTA 78 6.01.1.013

**78. Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

PREGUNTA 79 6.01.1.014

**79. Paciente con prurito, aumento grosor uñas en manos y pies, aumento volumen inguinal bilateral, foto de unas manos eritematosas, descamando:**

A) Linfoma cutáneo (sd sezary)
B) Sarna noruega
C) Psoriasis
D) Dermatitis crónica
E) Dermatitis atópica

PREGUNTA 80 6.01.1.016

**80. Mujer de 35 años con placas eritematosas en cuero cabelludo con alopecia cicatricial, fotosensibilidad y presencia de tapones foliculares. Lesiones similares en mejillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tinea capitis
B) Alopecia androgénica
C) Tricotilomanía
D) Lupus eritematoso discoide
E) Alopecia areata

PREGUNTA 81 6.01.1.016

**81. Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.**

A) Lupus cutáneo crónico
B) Dermatitis seborreica
C) Psoriasis
D) Liquen plano
E) Rosácea

PREGUNTA 82 6.01.1.029

**82. Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una lesión en la cara anterior de la pierna derecha, eritematosa y descama8va, que inició hace cerca de 12 meses y ha ido aumentando progresivamente de tamaño. Al examen Fsico se observa la siguiente lesión: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Psoriasis
B) Derma22s de contacto
C) Eccema numular
D) Enfermedad de Bowen
E) Tiña

PREGUNTA 83 6.01.6.002

**83. Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por escamas ásperas muy adherentes, que al frotarlas suavemente con el dedo se sienten rugosas como lija. No hay induración ni signos inflamatorios profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Queratosis actínicas
B) Queratosis seborreicas
C) Psoriasis vulgar
D) Lupus eritematoso discoide
E) Linfoma cutáneo de células T

PREGUNTA 84 6.01.6.002

**84. ¿Cuál de los siguientes fármacos tópicos está indicado para el tratamiento del "campo de cancerización" en pacientes con múltiples queratosis actínicas faciales?**

A) Clobetasol propionato al 0.05% en crema
B) Imiquimod al 5% en crema
C) Mupirocina al 2% en ungüento
D) Ketoconazol al 2% en crema
E) Metronidazol al 0.75% en gel

PREGUNTA 85 6.01.1.006

**85. Un escolar de 6 años es traído por su madre por presentar una placa redondeada de 4 cm en el cuero cabelludo, donde el pelo se ha caído parcialmente y los cabellos restantes se observan rotos a pocos milímetros de la superficie cutánea, con descamación superficial asociada y prurito leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A) Ketoconazol en crema al 2% aplicado dos veces al día por 2 semanas
B) Clobetasol tópico al 0.05% por sospecha de alopecia areata
C) Griseofulvina oral a 20 mg/kg/día durante 6 a 8 semanas
D) Permetrina al 1% en loción capilar en dosis única
E) Antibioticoterapia oral con cefadroxilo por 10 días

PREGUNTA 86 6.01.1.006

**86. Una mujer de 29 años consulta por intenso prurito nocturno en las manos y cuerpo de 10 días de evolución. Al examen se aprecian lesiones lineales milimétricas y pequeñas pápulas con excoriaciones en los espacios interdigitales de las manos y cara flexora de las muñecas. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es INDISPENSABLE para lograr la erradicación del cuadro?**

A) Indicar tratamiento antibiótico oral profiláctico con doxiciclina
B) Tratar simultáneamente a todos los contactos del hogar con permetrina al 5%, presenten o no síntomas
C) Indicar corticoides sistémicos a dosis altas para frenar el prurito de inmediato
D) Aplicar permetrina al 5% exclusivamente sobre las lesiones visibles de las manos
E) Desinfectar los muebles del hogar con soluciones cloradas concentradas

PREGUNTA 87 6.01.1.018

**87. Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophitum rubrum. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Itraconazol
B) Griseofulvina
C) Fluconazol
D) Terbinafina
E) Clotrimazol

PREGUNTA 88 6.01.1.019

**88. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pediculosis · 6.01.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pediculosis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 89 6.01.1.021

**89. Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras melicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Amoxicilina más ácido clavulánico
B) Macrólidos
C) Betametasona
D) Cefoperazona
E) Ciprofloxacino

PREGUNTA 90 6.01.1.022

**90. Una mujer de 18 años presenta una placa eritematosa y levemente pruriginosa, de 5 cm, en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño en todo el tronco. El diagnóstico más probable es:**

A) Tiña
B) Lupus cutáneo subagudo
C) Sífilis secundaria
D) Pitiriasis versicolor
E) Pitiriasis rosada

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 1** **Respuesta: A** **Fotodermatosis**

6.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Era una fitofotodermatosis por litre (árbol de la zona central chilena).

**PREGUNTA 2** **Respuesta: A** **Vitiligo**

6.01.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vitiligo" (6.01.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 3** **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.010), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 4** **Respuesta: C**

**Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel**

6.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un acné nódulo quístico, que se considera de Gpo inflamatorio severo. El acné comedoniano (leve) se trata con re

**PREGUNTA 5** **Respuesta: B**

**Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel**

6.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una rosácea clásica: aumenta con la exposición solar. El lupus sistémico también puede afectar las mejillas y aumentar con el sol, pero no tiene tantas pústulas. Además, el lupus cutáneo crónico es una o más placas, sin pústulas, de curso crónico.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: B**

**Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel**

6.01.1.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hecho de sobrepasar los bordes de la herida es lo característico de los queloides. Un porcentaje importante puede tener dolor durante la fase de mayor acGvidad. El cuerpo extraño (ej. reacción a sutura) suele ser más localizado. La úlcera de Marjolin es un cáncer de piel que se origina en quemaduras y cicatrices grandes.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel**

7.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Una colección circunscrita de líquido seroso, claro o hemático ubicada en la epidermis, cuyo diámetro es menor a 0.5 centímetros (en este caso 2 a 3 mm), corresponde por definición semiológica estricta a una Vesícula. Las ampollas o flictenas (C) tienen un tamaño mayor a 0.5 o 1 cm. Las pústulas (A) contienen material purulento desde su origen. Las pápulas (D) son lesiones sólidas sin líquido. Las erosiones (E) son lesiones secundarias por pérdida de sustancia. Perla. Colección líquida serosa menor a 0.5 cm es siempre una vesícula.

**PREGUNTA 8** **Respuesta: A**

7.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel**

La diferencia patognomónica entre erosión y úlcera radica en la profundidad anatómica del daño tisular y su capacidad regenerativa. La erosión (o excoriación) es una pérdida de sustancia superficial circunscrita que afecta exclusivamente a la epidermis, respetando la membrana basal; dado que la capa basal de queratinocitos puede regenerar el epitelio por mitosis, la erosión cura restitutio ad integrum SIN DEJAR NINGUNA CICATRIZ. En cambio, la úlcera es una pérdida de sustancia profunda que destruye la membrana basal y penetra hacia la dermis reticular o tejido celular subcutáneo; como la dermis no puede regenerarse mediante mitosis epitelial, el defecto se repara mediante tejido de granulación y síntesis de colágeno fibrótico, dejando SIEMPRE UNA CICATRIZ PERMANENTE. Perla. Erosión = solo epidermis y sin cicatriz; Úlcera = llega a dermis y deja cicatriz.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína**

Es una alopecia areata clásica.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína**

El uso de antibióticos tópicos en monoterapia (como clindamicina al 1% o eritromicina sola) induce de forma extraordinariamente rápida la selección y proliferación de cepas mutantes resistentes de Cutibacterium acnes, perdiendo toda su eficacia clínica en menos de 4 a 8 semanas. Las guías de práctica clínica internacionales y del MINSAL establecen como regla de oro mandatoria que los antibióticos tópicos NUNCA deben prescribirse solos, sino formulados en combinación con Peróxido de Benzoilo (el cual es un agente oxidante queratolítico frente al cual las bacterias no pueden desarrollar resistencia) o con un retinoide tópico. Perla. El antibiótico tópico en acné jamás se da solo: siempre con peróxido de benzoilo.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína**

La isotretinoína oral es uno de los teratógenos farmacológicos humanos más potentes conocidos, induciendo la embriopatía por retinoides (microtia, anomalías del SNC, defectos cardíacos conotruncales e hidrocefalia en > 30% de los fetos expuestos). Su prescripción en mujeres con potencial de fertilidad exige un programa de prevención de embarazo estricto: dos métodos anticonceptivos complementarios iniciados 1 mes antes de empezar el fármaco, dos pruebas de embarazo negativas previas y test de embarazo mensual durante y hasta 1 mes después del cese del tratamiento. Además, debido a sus efectos sistémicos, se deben controlar basal y periódicamente el perfil lipídico (riesgo de hipertrigliceridemia y pancreatitis) y las transaminasas hepáticas (hepatotoxicidad). Está contraindicado combinar con tetraciclinas (D) por riesgo de pseudotumor cerebri. Perla. Isotretinoína exige doble anticoncepción, test de embarazo y control lipídico/hepático.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico**

Es un carcinoma espinocelular clásico, en especial porque se describe como escamosa y ulcerada y tiene antecedente de fotoexposición. Los demás cánceres también se pueden ulcerar. El granuloma piógeno sangra mucho, pero es de aspecto rojo y húmedo.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico**

El cuadro de eritema centrofacial persistente con telangiectasias y pápulo-pústulas en ausencia de comedones en una mujer adulta de 44 años corresponde a una Rosácea Pápulo-pustulosa. El tratamiento tópico de primera línea de elección avalado por la evidencia clínica es el Metronidazol tópico al 0.75% o la Ivermectina tópica al 1% en crema (que actúa contra el ácaro Demodex y reduce la inflamación). El clobetasol (A) es un corticoide ultrapotente que está terminantemente contraindicado en rosácea porque provoca una rosácea esteroidea de rebote catastrófico. El adapaleno (C) es para acné y produciría excesiva irritación en la piel sensible con rosácea. Perla. Metronidazol o ivermectina tópica son la primera línea en rosácea pápulo-pustulosa.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico**

El criterio semiológico cardinal para el diagnóstico diferencial entre acné vulgar y rosácea es la presencia o ausencia de comedones. El comedón (abierto o cerrado) es la lesión elemental primaria y patognomónica del acné vulgar (originado por la hiperqueratinización infundibular folicular). En cambio, la rosácea es una enfermedad con disregulación vascular e inflamatoria que NUNCA cursa con formación de comedones. Si un paciente presenta pápulas, pústulas y eritema facial pero se constatan comedones al examen físico, el diagnóstico es Acné Vulgar y no Rosácea. Trampa. La rosácea puede tener pápulas, pústulas y eritema idénticos al acné, pero NUNCA comedones.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico**

Si bien la imagen no era un cáncer basocelular clásico, esa era la única respuesta aceptable.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: E**

6.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico**

Tanto por las queratosis actínicas (premalignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: B**

6.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno**

El cuadro corresponde a una Alopecia Androgenética masculina (calvicie común en patrón de Hamilton-Norwood). Su fisiopatología radica en la acción de la dihidrotestosterona (DHT) sobre receptores androgénicos de folículos susceptibles, provocando su miniaturización progresiva. El fármaco oral de primera línea de elección es el Finasteride (1 mg/día), un inhibidor competitivo selectivo de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, que reduce los niveles tisulares y séricos de DHT en aproximadamente un 70%, deteniendo la caída en más del 85% de los pacientes y estimulando el engrosamiento del cabello miniaturizado. Perla. Finasteride oral inhibe la 5-alfa reductasa y frena la alopecia androgenética.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

6.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno**

El efluvio telógeno agudo (específicamente el efluvio postparto o telogen effluvium) se produce por la caída brusca de los niveles de estrógenos placentarios que mantenían a los cabellos artificialmente en fase de anágeno durante el embarazo. Esto precipita el paso masivo y sincronizado de gran porcentaje de folículos a la fase de telógeno (fase de reposo y caída), manifestándose clínicamente 2 a 3 meses después del parto como una caída difusa y alarmante pero sin pérdida de orificios foliculares ni formación de placas circunscritas. El cuadro es enteramente benigno y autolimitado: el ciclo capilar se normaliza y el cabello se repuebla de forma completa y espontánea en los siguientes 6 meses. La conducta correcta es descartar ferropenia, tranquilizar a la madre y no indicar tratamientos invasivos. Perla. Caída difusa masiva de pelo 2-3 meses postparto es efluvio telógeno fisiológico.

---

## BLOQUE 2 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: B** **Granuloma piogénico**

6.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es un granuloma piógeno clásico. Eso sí, la foto era distinta.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: D** **Granuloma piogénico**

6.01.1.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Caso clínico oficial EUNACOM para Granuloma piogénico.

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A** Ántrax 6.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Ántrax" como urgencia clínica (6.01.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A** Loxocelismo 6.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Es un loxsocelismo cutáneo clásico.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: D** Loxocelismo 6.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere

Loxosceles laeta (araña de rincón)

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El desarrollo de lesiones cutáneas características de una dermatosis previa sobre áreas de piel sana que han sufrido un traumatismo físico, mecánico, químico o quirúrgico (como una herida, incisión, quemadura o rascado) se denomina Fenómeno Isomórfico de Koebner. Es un sello semiológico característico de la Psoriasis, del Liquen Plano y del Vitíligo. El signo de Darier (A) ocurre en mastocitosis (habón al frotar). El signo de Nikolsky (C) es el despegamiento epidérmico por presión en pénfigo o NET. La patergia (D) es la formación de una pústula estéril tras un pinchazo en enfermedad de Behçet o pioderma gangrenoso. Perla. Aparición de lesiones sobre cicatriz o trauma es el fenómeno de Koebner.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El brote eruptivo agudo de pápulas descamativas pequeñas ("en gotas de lluvia") en tronco y extremidades en un paciente pediátrico o adolescente, precedido 1 a 2 semanas antes por una infección faringoamigdalina estreptocócica por Streptococcus pyogenes, es la presentación arquetípica de la Psoriasis en Gotas o Guttata. Las toxinas superantigénicas estreptocócicas activan de forma masiva a los linfocitos T cutáneos. Tiene un excelente pronóstico, respondiendo muy bien a la erradicación del estreptococo con antibióticos (amoxicilina) y fototerapia natural o UVB. Perla. Erupción en gotas tras amigdalitis estreptocócica es psoriasis guttata.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Una de las contraindicaciones farmacológicas más universales y estrictas de la dermatología es el uso de corticosteroides por vía sistémica (oral, intramuscular o endovenosa) en pacientes con psoriasis vulgar. Aunque los corticoides orales provocan una mejoría clínica espectacular y rápida durante los primeros días de administración, su reducción o suspensión desencadena invariablemente un fenómeno de rebote severo y catastrófico, induciendo la transformación de la psoriasis vulgar en una Psoriasis Pustulosa Generalizada de von Zumbusch o una Eritrodermia Psoriásica, entidades graves con riesgo de descompensación hemodinámica, hipotermia, sobreinfección bacteriana y muerte. Trampa. NUNCA indicar prednisona oral en un brote de psoriasis vulgar.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La inflamación simultánea y difusa de toda la estructura de un dedo (que involucra las articulaciones interfalángicas, tendones flexores y partes blandas periarticulares), dándole un aspecto tumefacto cilíndrico homogéneo semejante a un embutido, se denomina Dactilitis o "dedo en salchicha". Es un signo patognomónico característico de las espondiloartropatías seronegativas asociadas a HLA-B27, particularmente de la Artritis Psoriásica (afectando a un 30% de estos pacientes). Se acompaña frecuentemente de compromiso de articulaciones interfalángicas distales (IFD), entesitis aquiliana y onicopatía psoriásica. Perla. Dedo en salchicha (dactilitis) en paciente psoriásico confirma artritis psoriásica.

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

6.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

Placas eritematosas con escamas plateadas en superficies extensoras + fenómeno de Auspitz (sangrado puntiforme al retirar escama) = psoriasis en placas. Compromiso 10% = psoriasis moderada.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: B**

6.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas**

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación**

El cuadro de lesiones eccematosas exudativas bilaterales intensamente pruriginosas en las mejillas y superficies extensoras de las extremidades en un lactante, con preservación estricta y absoluta de la región cubierta por el pañal, es la presentación semiológica clásica y definitoria de la Dermatitis Atópica en su fase del lactante. La dermatitis del pañal (A) comprometería precisamente el área del pañal. La dermatitis seborreica (D) afecta cuero cabelludo ("costra láctea"), pliegues y área del pañal con escamas untuosas y NO respeta el pañal ni causa prurito tan intenso. La acrodermatitis enteropática (E) por déficit de zinc produce placas erosivas periorificiales y diarrea. Perla. Eccema en mejillas que respeta el pañal es dermatitis atópica del lactante.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación**

La sobreinfección diseminada por el Virus Herpes Simple (VHS-1 o VHS-2) sobre una piel con dermatitis atópica con barrera epidérmica dañada se denomina Eccema Herpético de Kaposi (o erupción variceliforme de Kaposi). Se caracteriza por un brote agudo y masivo de vesículas umbilicadas agrupadas, dolorosas y confluentes que evolucionan a erosiones en sacabocados con costras hemáticas, acompañadas de fiebre alta y adenopatías. Constituye una verdadera emergencia dermatológica y pediátrica por el alto riesgo de diseminación visceral herpética, queratitis herpética y sobreinfección bacteriana secundaria. Requiere hospitalización urgente y tratamiento antiviral sistémico inmediato con Aciclovir endovenoso. Perla. Niño atópico con brote agudo de vesículas umbilicadas y fiebre tiene eccema herpético (Aciclovir EV).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

6.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Dermatitis del pañal" (6.01.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)**

El dicromato de potasio (sales de cromo hexavalente) es el alérgeno clásico presente en el cemento húmedo y constituye la causa profesional más frecuente de dermatitis de contacto alérgica grave e incapacitante en trabajadores de la construcción y albañiles. Dado que es una reacción de hipersensibilidad celular tipo IV mediada por linfocitos T, el método confirmatorio de certeza son las pruebas epicutáneas del parche (Patch test) con lectura a las 48 y 96 horas. El níquel (A) es típico de bisutería. El látex (C) produce hipersensibilidad inmediata tipo I con habones. Perla. Eccema de manos en trabajador de la construcción con cemento es alergia al cromo (dicromato de potasio).

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

6.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)**

La presencia de una Dermatitis Seborreica extensa, atípica, severa y refractaria a tratamiento convencional en un adulto joven, especialmente cuando se acompaña de signos de inmunodepresión celular como candidiasis orofaríngea recurrente o baja de peso, es un marcador clínico centinela de Primoinfección o infección avanzada por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La prevalencia de dermatitis seborreica alcanza entre el 40% y el 80% en pacientes seropositivos, con una severidad que se correlaciona inversamente con el recuento de linfocitos CD4. La conducta médica inmediata e inexcusable en atención primaria es ofrecer y solicitar el test de ELISA para VIH. Perla. Dermatitis seborreica severa o explosiva en adulto joven exige solicitar test de VIH.

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

6.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)**

Faltaba información y no era posible ver bien la imagen. Podría ser una dermatitis de contacto alérgica, porque era en relación a un aro y excedía la zona de contacto, pero las lesiones en la cara no calzaban del todo. La visualización de costras melicéricas es muy sugerente de impétigo (piodermitis superficial), pero también puede verse en la dermatitis de contacto y el cuadro es clásico de esta enfermedad. No puede ser celulitis, porque no hay tejido celular subcutáneo en la oreja.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: E**

6.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)**

Caso clínico oficial EUNACOM para Dermitis de contacto.

## BLOQUE 3 DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Líquen plano**

6.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Líquen plano" (6.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.006), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 39** **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 40** **Respuesta: E**

6.01.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos**

Tiene una celulitis. Se trata con antibióticos orales (solo si no tiene fiebre) o idealmente endovenosos, que cubran S. aureus (cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas de primera generación; en alérgicos a todos los betalactámicos: clindamicina).

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos**

El cuadro corresponde con total precisión a un Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) inducido por alopurinol. Presenta todos los elementos diagnósticos clásicos: latencia de 4 semanas (1 mes), fiebre alta persistente, exantema morbiliforme confluente con edema facial prominente (sello semiológico), eosinofilia marcada (> 1.500/uL), linfocitos atípicos en sangre y compromiso hepático evidente con elevación de transaminasas. En el SSJ (A) habría ampollas, desprendimiento epidérmico, Nikolsky positivo y compromiso mucoso hemorrágico severo, sin eosinofilia prominente. La psoriasis eritrodérmica (C) cursa con descamación laminar generalizada y no da hepatitis ni eosinofilia de este grado.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: C**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos**

Una de las características más importantes y preguntadas del Síndrome DRESS en el EUNACOM es su período de latencia inusualmente prolongado, que típicamente oscila entre 2 y 8 semanas (promedio 3 a 6 semanas) después de la primera dosis del fármaco responsable. Esto contrasta abiertamente con las reacciones anafilácticas o urticarias inmediatas (minutos a pocas horas), el exantema maculopapular benigno común (4 a 10 días) y el síndrome de Stevens-Johnson (1 a 3 semanas). Esta latencia tardía con frecuencia dificulta el reconocimiento inicial si el médico no indaga fármacos iniciados el mes previo.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos**

El hígado es, por amplio margen, el órgano interno más frecuentemente comprometido en el Síndrome DRESS, afectándose en el 75% al 90% de todos los casos confirmados. La presentación varía desde una elevación asintomática de transaminasas hasta una hepatitis tóxica severa con ictericia y coagulopatía, siendo la insuficiencia hepática aguda fulminante la principal causa de muerte por este síndrome (mortalidad global del 5% al 10%). El riñón (B) se afecta en un 15-30% de los casos (nefritis tubulointersticial, especialmente por alopurinol), pero con menor frecuencia que el hígado.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: C**

6.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos**

En el síndrome DRESS, el desescalamiento de la corticoterapia sistémica debe realizarse de forma extraordinariamente lenta y paulatina, a lo largo de 8 a 12 semanas (2 a 3 meses). Esto se debe a que la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T y la reactivación concomitante del herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) persisten activas mucho después de retirado el medicamento. Una suspensión rápida (en días o semanas cortas) provoca casi invariablemente un "efecto rebote" con recurrencia de la fiebre, reaparición del exantema y hepatitis fulminante grave. Mantenerla de por vida (D) es incorrecto y tóxico.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos**

La propiedad semiológica definitoria y sine qua non del habón de la urticaria es su carácter evanescente o fugaz: debido a que el edema vasomotor de la dermis papilar se reabsorbe con rapidez, cada lesión individual tiene una duración efímera, desapareciendo por completo en menos de 24 horas sin dejar ninguna mancha, hematoma ni cicatriz en la piel afectada, mientras brotan nuevas lesiones en otras localizaciones anatómicas. Si la lesión permanece fija por más de 24-48 horas o deja una pigmentación purpúrica hemosiderótica al resolverse (A, C, E), orienta a una vasculitis urticariana. Perla. El habón de la urticaria dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

**Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos**

6.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El algoritmo internacional estandarizado de las guías EAACI/GA²LEN/EDF/WAO para el tratamiento de la urticaria crónica refractaria establece claramente que, ante el fracaso terapéutico de un antihistamínico H1 de segunda generación a dosis estándar transcurridas 2 a 4 semanas, el segundo escalón mandatorio es incrementar la dosis del mismo antihistamínico H1 de segunda generación hasta dos, tres o cuatro veces la dosis habitual (hasta 4 veces la dosis convencional, ej. cetirizina 40 mg/día o levocetirizina 20 mg/día). Esta estrategia logra el control en más del 60-70% de los pacientes refractarios con un excelente perfil de seguridad. Los corticoides orales a largo plazo (A) están contraindicados. Los antihistamínicos de primera generación como clorfenamina (C) ya no se recomiendan por sus efectos sedantes y anticolinérgicos. Perla. En urticaria refractaria a dosis estándar, se cuadruplica el antihistamínico de 2.ª generación.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: A**

**Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos**

6.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Urticaria aguda sin anafilaxia: antihistamínicos H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, loratadina) son primera línea. Corticoides se reservan para casos refractarios.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos**

6.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Angioedema de Quinque" como urgencia clínica (6.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: A**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico presentado, junto con la imagen, son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: B**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro corresponde a un Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y el signo semiológico descrito es el Signo de Nikolsky positivo. El SSJ se define por el desprendimiento epidérmico en menos del 10% de la superficie corporal total con compromiso severo de al menos dos mucosas (oral y ocular en este caso). El Signo de Nikolsky consiste en el despegamiento o desprendimiento de la epidermis al aplicar una suave fricción tangencial sobre la piel eritematosa o perilesional, lo que traduce necrosis epidérmica aguda o acantolisis. Si el compromiso fuera > 30% sería NET (C). El eritema multiforme menor (A) respeta mucosas o afecta una sola de forma leve y Nikolsky es negativo. Auspitz (D) es rocío sangrante en psoriasis.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: D**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La clasificación internacional del consenso dermatológico estratifica el espectro SSJ/NET según el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida con necrosis epidérmica de espesor total: 1) Síndrome de Stevens-Johnson: afectación menor al 10% de la BSA; 2) Síndrome de Superposición SSJ/NET: afectación entre 10% y 30% de la BSA; 3) Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Síndrome de Lyell): desprendimiento en más del 30% de la BSA. Recordar: corte menor al 10% es SSJ, corte mayor al 30% es NET.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: C**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El score pronóstico SCORTEN consta de 7 variables evaluadas al ingreso (1 punto cada una): 1) Edad ≥ 40 años; 2) FC ≥ 120 lpm; 3) Neoplasia activa; 4) Superficie epidérmica desprendida inicial > 10%; 5) BUN > 28 mg/dL (> 10 mmol/L); 6) Bicarbonato sérico < 20 mEq/L; 7) Glicemia > 252 mg/dL (> 14 mmol/L). En este paciente, el bicarbonato de 16 mEq/L es menor a 20 mEq/L, por lo que suma un punto de gravedad. La edad de 35 años no suma punto (el corte es ≥ 40 años), la FC de 95 lpm no suma punto (el corte es ≥ 120 lpm), la glicemia de 140 mg/dL no suma (corte > 252 mg/dL) y el BUN de 15 mg/dL tampoco suma (corte > 28 mg/dL).

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A diferencia de las quemaduras térmicas profundas de tercer grado, en la Necrólisis Epidérmica Tóxica el desbridamiento quirúrgico agresivo de la epidermis desprendida está CONTRAINDICADO. La epidermis necrótica desprendida actúa como un apósito biológico natural que protege la dermis papilar subyacente y favorece la reepitelización sin cicatriz profunda si no se somete a tracción traumática. Las ampollas grandes pueden aspirarse con aguja estéril preservando el techo de la flictena y cubriendo con gasas no adherentes. El ambiente térmico cálido (A), la protección ocular intensiva para prevenir simbléfaron (C), la fluidoterapia controlada (D) y el retiro farmacológico precoz (E) son pilares fundamentales de la buena práctica médica.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: D**

**Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)**

6.01.2.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.

---

## BLOQUE 4 FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A**

**Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos**

6.01.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos" (6.01.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido**

6.01.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido" como urgencia clínica (6.01.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A** **Inicial**

6.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Inicial" como urgencia clínica (6.01.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento No requiere. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

6.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pénfigo" (6.01.1.020), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

El cuadro clínico es patognomónico de Penfigoide Ampollar. Los hallazgos cardinales que lo confirman son: 1) Edad avanzada (76 años con patología neurológica crónica asociada); 2) Prurito intenso prodrómico; 3) Ampollas tensas, de paredes gruesas y resistentes que no se rompen fácilmente; 4) Signo de Nikolsky negativo (la epidermis sana no se desprende con la fricción); y 5) Ausencia de compromiso en la mucosa oral. El pénfigo vulgar (A) afectaría a personas más jóvenes (40-60 años), cursaría con ampollas flácidas muy frágiles, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal. La NET (C) es una farmacodermia aguda grave con Nikolsky positivo y desprendimiento masivo. La dermatitis herpetiforme (D) se asocia a celiaquía con vesículas en codos y rodillas.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

El hallazgo histopatológico diagnóstico del Pénfigo Vulgar es la ampolla intraepidérmica de localización suprabasal con acantolisis (pérdida de uniones desmosómicas entre queratinocitos mediada por anticuerpos anti-desmogleína 3). La hilera de queratinocitos de la capa basal permanece adherida a la membrana basal mediante sus hemidesmosomas indemnes, adoptando el clásico aspecto de "hilera de lápidas sepulcrales". La ampolla subepidérmica (A) es propia del penfigoide ampollar y dermatitis herpetiforme. La ampolla subcórnea (C) es del impétigo ampollar o pénfigo foliáceo. La necrosis epidérmica total (D) es de la NET. La vacuolización basal en banda (E) es del liquen plano.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

El pilar fundamental e irremplazable de primera línea para el tratamiento del Pénfigo Vulgar agudo son los Corticoides Sistémicos en dosis altas (Prednisona oral a 1.0 a 1.5 mg/kg/día, o pulsos endovenosos de metilprednisolona en formas hiperagudas fulminantes). Debido a la alta morbimortalidad de los corticoides a largo plazo, se asocian precozmente a agentes biológicos como Rituximab (anti-CD20) o inmunosupresores como azatioprina o micofenolato como ahorradores de corticoides. La dapsona con dieta sin gluten (C) es el tratamiento de la dermatitis herpetiforme asociada a celiaquía. El aciclovir (D) trata herpes. Los antihistamínicos (B) no frenan la acantolisis autoinmune.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: C**

6.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

En el Penfigoide Ampollar, la inmunofluorescencia directa (IFD) sobre piel perilesional revela un depósito continuo y lineal de IgG y factor C3 del complemento a lo largo de la zona de la membrana basal (unión dermoepidérmica), donde se ubican los antígenos hemidesmosómicos BP180 y BP230. En contraste, el pénfigo vulgar (B) muestra un depósito intercelular de IgG en patrón de "red de pescar" o "malla" en la epidermis. El depósito granular de IgA en las papilas dérmicas (A) es patognomónico de la dermatitis herpetiforme de Duhring-Brocq.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

6.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pénfigo y penfigoide" como urgencia clínica (6.01.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

6.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin" (6.01.1.009), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: A**

6.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Eritema polimorfo menor" (6.01.1.010), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: D**

6.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

Es una verruga paraungueal clásica. La descripción era muy clara. La imagen era algo más confundente.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

6.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

La presencia de lesiones en diana o escarapela típica con 3 anillos concéntricos en extremidades acrales, asociadas al antecedente inmediato de herpes labial (7 a 14 días previos), es el cuadro clásico indiscutible de un Eritema Multiforme inducido por Virus Herpes Simple (VHS). El VHS es el responsable de más del 70% de todos los casos de eritema multiforme. El SSJ (A) cursa con dianas atípicas de solo dos zonas, Nikolsky positivo, flictenas con desprendimiento epidérmico y compromiso mucoso severo. La urticaria multiforme (C) produce habones evanescentes migratorios que duran menos de 24 horas cada uno. El penfigoide (D) da ampollas tensas en ancianos.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

6.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

En pacientes con Eritema Multiforme recurrente frecuente (más de 3 a 5 episodios al año) asociado a reactivaciones documentadas de Virus Herpes Simple (VHS), la indicación médica con mayor nivel de evidencia es la profilaxis o terapia supresiva continua con antivirales orales: Aciclovir oral (400 mg cada 12 horas) o Valaciclovir (500 mg una vez al día) durante 6 a 12 meses. Esta estrategia suprime la replicación del ADN viral del VHS en los ganglios sensitivos, previniendo el estímulo inmunológico antigénico en la piel y evitando las recidivas en más del 80% de los casos. Los corticoides sistémicos continuos (A) están contraindicados por su severa toxicidad acumulativa.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: E**

6.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple**

Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos**

Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo. Esta técnica permite la extirpación diagnóstica íntegra y asegura la medición histológica fidedigna del espesor de Breslow, sin desestructurar la arquitectura de la lesión.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

**Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos**

6.01.1.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos**

6.01.1.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vasculitis cutáneas" (6.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

## BLOQUE 5 ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: D** Sarna

6.01.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sarna Nodular: La presencia de prurito en la zona genital puede ser compatible con escabiosis (sarna) o infestación por ladillas (Phthirus pubis). Sin embargo, si las imágenes muestran lesiones nodulares características, se confirma el diagnóstico de sarna nodular.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: A** Completo

6.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Completo" como urgencia clínica (6.01.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A** Completo

6.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Completo" como urgencia clínica (6.01.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La tríada semiológica de pápula translúcida con brillo perlado, telangiectasias arboriformes superficiales y ulceración central ("úlcera de Rodent") en una zona fotoexpuesta facial (nariz) es patognomónica del Carcinoma Basocelular, el tumor maligno cutáneo más frecuente.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

1.08.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Toda úlcera o placa costrosa indurada en el labio inferior que no cicatriza en más de 2 a 4 semanas debe considerarse un Carcinoma Espinocelular (CEC) hasta demostrar lo contrario. El labio inferior es una localización de alto riesgo para CEC (precedido comúnmente por queilitis actínica) y tiene un riesgo significativo de metástasis a ganglios submentonianos y submandibulares.

**PREGUNTA 78** **Respuesta: A**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

6.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles (≥5) obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: A**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

6.01.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 113). Evalúa el manejo clínico de Linfomas cutáneos según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: D**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

6.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Lupus discoide: placas eritematosas con escamas adherentes, tapones foliculares y alopecia cicatricial en cuero cabelludo + fotosensibilidad en mejillas. Alopecia cicatricial permanente. Tratamiento: antipalúdicos (cloroquina) + protección solar.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

**Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)**

6.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide).

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: D**

**Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos**

6.01.1.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Si bien por la ubicación y aspecto se podía pensar en una psoriasis, la edad, la evolución y la presencia de una única lesión es característica de la enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Fuente imagen: hxps://iqb.es/dermatologia.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos**

6.01.6.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Las máculas eritematosas poco delimitadas con escamas adherentes ásperas al tacto (signo de la lija) en zonas fotoexpuestas crónicas son patognomónicas de las Queratosis Actínicas, lesiones premalignas inducidas por daño solar ultravioleta acumulativo.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

**Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos**

6.01.6.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El Imiquimod al 5% en crema es un inmunomodulador tópico aprobado y ampliamente utilizado para tratar el campo de cancerización en queratosis actínicas múltiples, ya que estimula la respuesta inmune innata y adaptativa local eliminando queratinocitos atípicos subclínicos en toda el área fotoexpuesta.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: C**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde a una Tiña de la Cabeza (Tinea capitis), producida comúnmente por Microsporum canis. La regla de oro en dermatología pediátrica es que la tiña capitis requiere SIEMPRE tratamiento antimicótico por vía oral (Griseofulvina oral durante 6 a 8 semanas, administrada idealmente con alimentos grasos para mejorar su absorción), ya que los antimicóticos tópicos no logran penetrar la raíz del folículo piloso afectado.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En la escabiosis, el pilar más crítico para evitar el fracaso terapéutico y las reinfecciones continuas en "ping-pong" es tratar de forma simultánea a TODOS los convivientes y contactos estrechos del paciente con permetrina al 5% en crema (o ivermectina oral), independientemente de si presentan síntomas clínicos o no, ya que el período de incubación asintomático puede durar hasta 4 a 6 semanas.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: D**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La terbinafina oral es el tratamiento de elección de la onicomicosis.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pediculosis" (6.01.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un impétigo. Cloxacilina o cefadroxilo habrían sido de elección, pero la amoxicilina más ácido clavulánico cubren bien al S. Aureus y al S. Pyogenes, que son los agentes etiológicos.

---

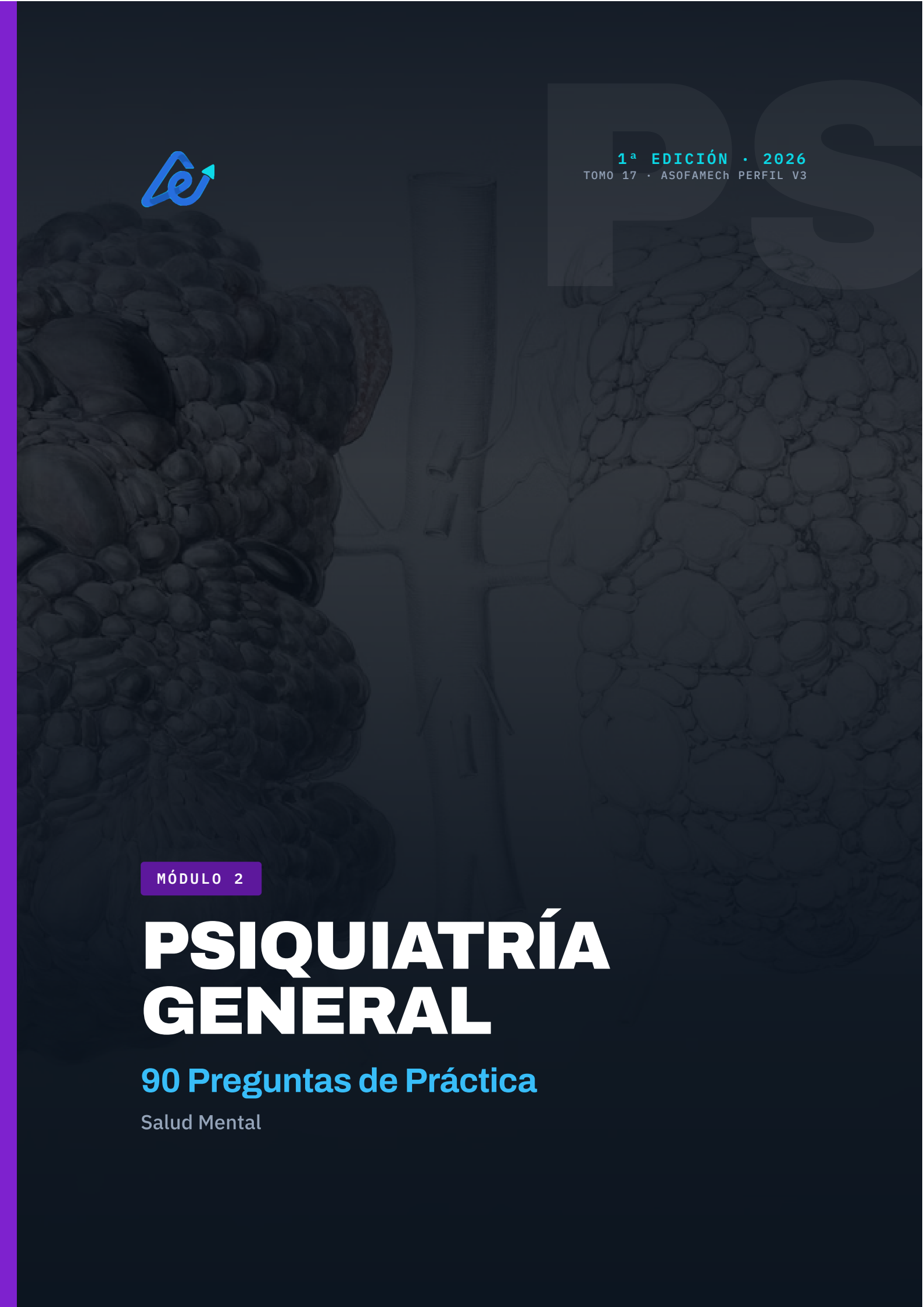
**PREGUNTA 90** **Respuesta: E**

**Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis**

6.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una pitiriasis rosada de Gibert clásica, con la mancha heráldica y la posterior aparición del exantema rosado y descamativo. Puede o no tener prurito.

---



1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 17 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 2

# PSIQUIATRÍA GENERAL

## 90 Preguntas de Práctica

Salud Mental

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Psiquiatría General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS** | | | | | |
| 4.01.1.001 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 5.01.1.004 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.007 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q5 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.008 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.009 | Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.013 | Dependencia de otras drogas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.015 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.020 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.021 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.022 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.023 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.024 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q12 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.028 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q13 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.029 | Intento de suicidio en niños y adolescentes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.032 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q14 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.033 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q15 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.034 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | GES | Q16 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Completo** | | | |
| 5.01.2.001 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS** | | | | | |
| 1.03.1.003 | Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q23, Q24, Q25, Q26 | Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24) |
| 1.09.1.006 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.11.1.002 | Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q21, Q22 | Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17) |
| 1.13.1.004 | Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35 | Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30) |
| 5.01.1.001 | Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 17 · C.2 (Pág. 8) |
| 5.01.1.002 | Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 17 · C.50 (Pág. 104) |
| 5.01.1.003 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.017 | Disfunción sexual | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.035 | Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q20 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.036 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA** | | | | | |
| 1.05.1.002 | Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.13.1.004 | Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q47, Q48 | Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30) |
| 5.01.1.005 | Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q49 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.006 | Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 17 · C.11 (Pág. 26) |
| 5.01.1.010 | Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.019 | Sexualidad humana y sus alteraciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS** | | | | | |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.1.001 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68, Q69 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.2.001 | Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.13.2.001 | Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q58, Q59, Q60, Q61 | Tomo 17 · 17.13 (Pág. 45) |
| 4.01.1.001 | Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q56, Q57 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 5.01.1.012 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.014 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.025 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.026 | Enuresis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.2.002 | Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL** | | | | | |
| 1.09.1.001 | Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q78, Q79 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 4.01.1.001 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q86, Q87 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 5.01.1.011 | Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q74, Q75, Q76 | Tomo 17 · 17.16 (Pág. 60) |
| 5.01.1.016 | Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.018 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.027 | Encopresis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.030 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q89 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.031 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.2.003 | Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Psiquiatría General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 17 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.003 | Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q23, Q24, Q25, Q26 | Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24) |
| 1.05.1.002 | Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46 | Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11) |
| 1.09.1.001 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q67, Q68, Q69, Q78, Q79 | Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37) |
| 1.09.1.006 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q30, Q31 | Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58) |
| 1.09.2.001 | Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 17 · 17.3 (Pág. 13) |
| 1.11.1.002 | Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q21, Q22 | Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17) |
| 1.13.1.004 | Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35, Q47, Q48 | Tomo 17 · 17.8 (Pág. 30) |
| 1.13.2.001 | Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q58, Q59, Q60, Q61 | Tomo 17 · 17.13 (Pág. 45) |
| 4.01.1.001 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3, Q56, Q57, Q86, Q87 | Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5) |
| 5.01.1.001 | Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q27, Q28, Q29 | Tomo 17 · C.2 (Pág. 8) |
| 5.01.1.002 | Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 17 · C.50 (Pág. 104) |
| 5.01.1.003 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.004 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.005 | Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q49 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.006 | Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50, Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 17 · C.11 (Pág. 26) |
| 5.01.1.007 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q5 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.008 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.1.009 | Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.010 | Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42, Q43, Q44 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.011 | Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q74, Q75, Q76 | Tomo 17 · 17.16 (Pág. 60) |
| 5.01.1.012 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q70 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.013 | Dependencia de otras drogas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.014 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.015 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.016 | Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.017 | Disfunción sexual | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.018 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.019 | Sexualidad humana y sus alteraciones | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.020 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.021 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.022 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.023 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.024 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q12 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.025 | Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q72 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.026 | Enuresis | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.027 | Encopresis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.1.028 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q13 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.029 | Intento de suicidio en niños y adolescentes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.030 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q89 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.031 | Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.032 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q14 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.033 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q15 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.034 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q16 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.035 | Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q20 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.1.036 | Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.2.001 | Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.2.002 | Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |
| 5.01.2.003 | Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q77 | Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

PREGUNTA 1 5.01.1.013

**1.** **Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?**

A) Terapia cognitiva conductual
B) Parches de nicotina
C) Bupropión
D) Fluoxetina
E) Vareniclina

PREGUNTA 2 5.01.1.029

**2.** **Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?**

A) Gases arteriales
B) Bilirrubinemia
C) Electrocardiograma
D) Creatinfosfoquinasa
E) Pruebas hepáticas

PREGUNTA 3 4.01.1.001

**3.** **Una mujer de 38 años consulta por un cuadro de 5 semanas de evolución caracterizado por ánimo persistentemente bajo, anhedonia, pérdida de 3 kg de peso, dificultad para concentrarse en su trabajo y despertar precoz con angustia matinal. Niega antecedentes mórbidos y su examen físico es normal. Se aplica escala PHQ-9 con resultado de 16 puntos. No presenta ideación suicida ni antecedentes personales o familiares de manía. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada según la guía clínica GES?**

A) Indicar Clonazepam 1 mg cada 12 horas por 3 meses y control al término del tratamiento
B) Iniciar Sertralina 50 mg al día, asociar psicoterapia, educar sobre la latencia de 2 a 4 semanas y controlar en 2 semanas
C) Derivar inmediatamente a hospitalización psiquiátrica cerrada para inicio de terapia electroconvulsiva
D) Indicar reposo laboral exclusivo por 30 días sin iniciar psicofármacos hasta una segunda evaluación
E) Iniciar Amitriptilina 150 mg al día junto con Haloperidol 5 mg cada noche

PREGUNTA 4 5.01.1.004

**4.** **Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por somatización
B) Depresión mayor
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 5 5.01.1.007

**5.** **Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?**

A) Alprazolam
B) Sertralina
C) Quetiapina
D) Carbonato de litio
E) Amitriptilina

PREGUNTA 6 5.01.1.008

**6.** **Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de escitalopram
B) Cambiar el tratamiento a venlafaxina
C) Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
D) Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
E) Cambiar el tratamiento a fluoxetina

PREGUNTA 7 5.01.1.015

**7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Trastornos neurocognitivos · 5.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastornos neurocognitivos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 5.01.1.020

**8. Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno dismórfico corporal
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno facticio
D) Trastorno somatomorfo
E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 9 5.01.1.021

**9. Una mujer de 18 años sufrió un rapto al salir de la oficina, por dos desconocidos. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente, sin lesiones físicas. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de lo sucedido, recordando solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno facticio
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

PREGUNTA 10 5.01.1.022

**10. Una paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Se solicitan exámenes, descartándose patología orgánica. Además, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno delirante
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de la conducta alimentaria

PREGUNTA 11 5.01.1.023

**11. Un paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad, en los que rompe objetos, grita, amenaza con agredir y con autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas, las que le cuesta mucho modificar. Abandonó la secundaria, ya que reprobó dos veces primero medio. Además, tiene muy buena memoria, al punto que puede memorizar los códigos de barras de distintos productos. Desde niño que fue considerado como raro, no entablaba amistades y jugaba solo siempre con el mismo juguete, además de ver repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda a las personas de una manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno del especto autista
E) Trastorno estereotipado del movimiento

PREGUNTA 12 5.01.1.024

**12. [ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno específico del aprendizaje escolar · 5.01.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno específico del aprendizaje escolar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 13 5.01.1.028

**13.** **Una mujer de 30 años, ingeniera civil, refiere que desde su infancia se le pierden con frecuencia las cosas y que le es diFcil realizar tareas, en especial porque las procras8na y le cuesta terminarlas una vez iniciadas. Por ello realiza listas de todas las cosas que debe hacer a modo de cumplir con ellas. Recientemente, en su trabajo ha aumentado su carga laboral y responsabilidades, lo que la 8ene agobiada y angus8ada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Trastorno del espectro au2sta
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
E) Trastorno de angus2a generalizada

PREGUNTA 14 5.01.1.032

**14.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno somatización en niños · 5.01.1.032] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno somatización en niños. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 15 5.01.1.033

**15.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Trastornos ansiosos en niños · 5.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastornos ansiosos en niños. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 5.01.1.034

**16.** **Un adolescente de 16 años presenta, desde hace 3 meses, anhedonia, disminución en su rendimiento escolar y presencia de pensamientos negativos sobre sí mismo y su situación, con aislamiento social. Además, relata dificultades para concentrarse en sus actividades académicas e insomnio tanto de inicio como de mantención. Ha subido 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Niega autoagresiones y no tiene ideación suicida actual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Distimia
B) Trastorno del espectro autista
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad

PREGUNTA 17 5.01.2.001

**17.** **[URGENCIA: Conducta suicida · 5.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Conducta suicida. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 18 5.01.1.009

**18.** **Paciente de 35 años con episodios previos de tristeza profunda de 3 semanas de duración. Ahora consulta por irritabilidad, euforia, grandiosidad, insomnio sin cansancio y gastó todos sus ahorros en 4 días. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno bipolar tipo I
B) Trastorno depresivo mayor recurrente
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de personalidad borderline

PREGUNTA 19 5.01.1.017

**19. Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

PREGUNTA 20 5.01.1.035

**20. ¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?**

A) Riesgo de dependencia a la marihuana
B) Riesgo de intoxicación aguda
C) Desarrollo de esquizofrenia
D) Disminución de la motivación escolar
E) Desarrollo de alcoholismo

PREGUNTA 21 1.11.1.002

**21. Un hombre de 26 años consulta en el CESFAM por llanto fácil, insomnio de conciliación y desconcentración de 4 semanas de evolución. Refiere que hace 6 semanas terminó una relación de pareja de 3 años de duración. Al examen mental se aprecia angustiado, pero mantiene reactividad afectiva, sale a correr por las tardes, se alimenta bien y no presenta anhedonia generalizada ni ideas de muerte. Su PHQ-9 resulta en 6 puntos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada?**

A) Trastorno depresivo mayor grave; iniciar Sertralina 100 mg al día e interconsulta a COSAM
B) Trastorno adaptativo con ánimo depresivo; indicar psicoterapia de apoyo breve y consejería sin psicofármacos
C) Trastorno de pánico; prescribir Clonazepam 2 mg cada 8 horas por 6 meses
D) Distimia crónica; indicar antidepresivos tricíclicos por 2 años
E) Trastorno bipolar tipo II; iniciar carbonato de litio inmediato

PREGUNTA 22 1.11.1.002

**22. Una mujer de 39 años consulta en salud mental refiriendo: "Toda mi vida he sido una persona triste y sin energía; desde la universidad, hace más de 10 años, siento que veo el mundo en blanco y negro, me canso con facilidad y tengo muy baja autoestima". Refiere que nunca ha tenido episodios de euforia ni períodos libres de síntomas que superen las 3 o 4 semanas seguidas. Su examen físico y tiroideo son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico?**

A) Trastorno adaptativo; reposo laboral exclusivo
B) Trastorno Depresivo Persistente (Distimia); tratamiento combinado con ISRS a largo plazo y psicoterapia cognitivo-conductual
C) Trastorno de personalidad esquizoide; tratamiento con antipsicóticos típicos
D) Episodio depresivo mayor único; suspensión de fármacos a los 3 meses
E) Trastorno ciclotímico; monoterapia con valproato sódico

PREGUNTA 23 1.03.1.003

**23. Una mujer de 29 años llega al servicio de urgencias por tercera vez en el mes manifestando sensación de ahogo, opresión en el pecho, taquicardia y miedo inminente a morir, iniciado bruscamente hace 20 minutos mientras estaba sentada en su trabajo. Su ECG, hemograma, enzimas cardíacas y radiografía de tórax resultan normales. Relata que vive con angustia constante pensando cuándo volverá a repetirse el episodio y ha evitado salir sola a la calle. ¿Cuál es la estrategia farmacológica de mantenimiento más adecuada?**

A) Indicar Alprazolam 0.5 mg cada 8 horas en monoterapia continua por un año
B) Iniciar Sertralina a dosis inicial de 25 mg al día titulando a 50 mg al día, asociar psicoterapia cognitivo-conductual y usar benzodiacepinas solo como puente transitorio
C) Prescribir Propranolol 80 mg cada 12 horas como monoterapia de por vida
D) Indicar Haloperidol 5 mg en gotas en caso de angustia y dar el alta sin controles
E) Mantener conducta expectante sin fármacos ya que todos los exámenes resultaron normales

PREGUNTA 24 1.03.1.003

**24. Un hombre de 24 años consulta en urgencias por palpitaciones violently intensas, parestesias en dedos de las manos, temblor y sensación de atragantamiento que iniciaron hace 15 minutos. El examen cardiopulmonar y el ECG son rigurosamente normales. El médico tratante concluye que se trata de un ataque de pánico agudo. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado en la sala de urgencias?**

A) Administrar Adenosina 6 mg endovenosa en bolo rápido
B) Realizar contención verbal, tranquilizar en box silencioso, entrenar respiración pausada y administrar Clonazepam 0.5 a 1 mg sublingual u oral si no cede
C) Indicar intubación orotraqueal por riesgo inminente de paro respiratorio
D) Administrar Morfina 10 mg subcutánea para calmar la sensación de opresión
E) Hacer respirar al paciente en una bolsa plástica herméticamente cerrada durante 15 minutos ininterrumpidos

PREGUNTA 25 1.03.1.003

**25. Un paciente de 36 años con diagnóstico reciente de trastorno de pánico inicia tratamiento con Fluoxetina 20 mg/día. Al cuarto día acude muy alarmado al consultorio señalando que siente "más temblor, más palpitaciones y más angustia que antes de empezar las pastillas", pensando que el fármaco le hizo daño. ¿Cuál es la explicación neurobiológica y la conducta médica adecuada?**

A) Es una reacción alérgica grave; suspender inmediatamente todo antidepresivo
B) Es una hiperactivación serotoninérgica 5-HT inicial transitoria; educar al paciente, reducir temporalmente la dosis a la mitad (10 mg) y considerar un ansiolítico puente
C) El paciente desarrolló un infarto agudo al miocardio; trasladar de inmediato a hemodinamia
D) El paciente finge los síntomas para obtener licencia; dar el alta sin indicaciones
E) Duplicar la dosis de Fluoxetina a 40 mg para vencer la resistencia

PREGUNTA 26 1.03.1.003

**26. Una mujer de 40 años que sufrió múltiples ataques de pánico hace 6 meses ha dejado de utilizar el transporte público, no acude a centros comerciales ni supermercados, y únicamente sale a la puerta de su casa si va acompañada por su esposo, refiriendo pánico a "quedarse atrapada y no poder escapar si le viene una crisis". ¿Cuál es el diagnóstico complementario y el tratamiento psicoterapéutico más eficaz?**

A) Trastorno delirante persecutorio; psicoterapia psicoanalítica
B) Agorafobia; Terapia Cognitivo-Conductual con técnicas de exposición interoceptiva y en vivo
C) Trastorno de personalidad obsesiva; hipnoterapia regresiva
D) Fobia social pura; relajación muscular progresiva exclusiva
E) Trastorno conversivo; hospitalización psiquiátrica prolongada

PREGUNTA 27 5.01.1.001

**27. Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de pánico
B) Agorafobia
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Crisis de pánico

PREGUNTA 28 5.01.1.001

**28. Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con "imposibilidad de sacar el aire", vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A) Amitriptilina 25 mg/día
B) Sertralina 50 mg/día
C) Risperidona 3 mg/día
D) Clonazepam 2 mg/día
E) Clorpromazina 300 mg/día

PREGUNTA 29 5.01.1.001

**29. Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?**

A) Inhibidores de la monoaminoxidasa
B) Benzodiacepinas
C) Antipsicóticos atípicos
D) Antidepresivos tricíclicos
E) Inhibidores de la recaptura de serotonina

PREGUNTA 30 1.09.1.006

**30. Una abogada de 34 años consulta por tensión muscular cervical continua, bruxismo, irritabilidad y preocupación excesiva por su desempeño laboral, sus finanzas y la salud de sus hijos, presente durante los últimos 8 meses. Refiere que le resulta imposible desconectarse de sus pensamientos y tarda más de 2 horas en conciliar el sueño. Su examen físico no muestra alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento de primera línea?**

A) Crisis de pánico; Clonazepam 2 mg sublingual cada vez que sienta angustia
B) Trastorno de Ansiedad Generalizada; iniciar Escitalopram o Sertralina asociado a Terapia Cognitivo-Conductual
C) Trastorno de personalidad obsesiva; psicoterapia psicoanalítica exclusiva
D) Depresión psicótica; iniciar Haloperidol 5 mg al día
E) Fobia social; prescribir Propranolol diario matinal

PREGUNTA 31 1.09.1.006

**31. Un estudiante universitario de 22 años consulta porque debe presentar su tesis de titulación frente a una comisión académica en dos semanas. Refiere que en su vida social habitual comparte normalmente con amigos y familia, pero cada vez que debe hablar frente a un público numeroso experimenta taquicardia violenta, temblor incontrolable en las manos, sudoración fría y rubor facial intenso que le impiden exponer. Niega síntomas ansiosos en su vida diaria. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta farmacológica más adecuada?**

A) Trastorno de pánico; iniciar Sertralina 100 mg al día por 1 año
B) Fobia social circunscrita a la actuación en público; indicar Propranolol 10 a 40 mg vía oral 30 a 60 minutos antes de la disertación
C) Trastorno de ansiedad generalizada; indicar Clonazepam 2 mg diario
D) Trastorno adaptativo; indicar reposo médico y suspensión de la titulación
E) Agorafobia grave; iniciar Terapia Electroconvulsiva

PREGUNTA 32 5.01.1.003

**32. Paciente de 28 años con miedo intenso y síntomas físicos ante situaciones de hablar en público o comer frente a otros. Evita reuniones sociales y ha rechazado ascensos laborales por esto. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea?**

A) Escitalopram (ISRS)
B) Propranolol a demanda
C) Alprazolam a diario
D) Haloperidol
E) Carbamazepina

PREGUNTA 33 5.01.1.036

**33.** **Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno obsesivo compulsivo
B) Trastorno de pánico
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Reacción adversa a las benzodiazepinas
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 34 1.13.1.004

**34.** **Un hombre de 26 años consulta porque desde hace 6 meses siente la necesidad imperiosa de revisar la cerradura de la puerta de su departamento exactamente 12 veces antes de salir, por temor a que entren ladrones. Reconoce que esta conducta es ridícula y absurda, pero si intenta no realizarla experimenta una angustia intolerable. La rutina le hace llegar tarde a su trabajo a diario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la psicoterapia de elección?**

A) Trastorno de la personalidad anancástico; psicoanálisis clásico
B) Trastorno Obsesivo-Compulsivo; Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición y Prevención de Respuesta
C) Esquizofrenia paranoide incipiente; terapia ocupacional
D) Trastorno delirante celotípico; terapia familiar sistémica
E) Fobia social; desensibilización sistemática a la interacción

PREGUNTA 35 1.13.1.004

**35.** **Un paciente de 29 años con diagnóstico de TOC inició tratamiento con Fluoxetina 20 mg/día hace 4 semanas por indicación de médico general. En el control refiere no haber notado ninguna mejoría en sus rituales de orden y simetría, tolerando bien el medicamento. Pregunta si debe abandonar el tratamiento por ineficaz. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Suspender la Fluoxetina y catalogar al paciente como refractario absoluto
B) Explicar que en el TOC se requieren dosis de ISRS más altas (titular Fluoxetina hasta 60 a 80 mg al día) y tiempos de espera de 8 a 12 semanas para evaluar la respuesta
C) Cambiar de inmediato a Clonazepam 2 mg cada 8 horas
D) Indicar internación inmediata en un hospital psiquiátrico cerrado
E) Asociar Haloperidol 10 mg al día en monoterapia

PREGUNTA 36 5.01.1.002

**36.** **Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de ansiedad
B) Ansiedad específica
C) Trastorno dismórfico corporal
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno obsesivo compulsivo

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

PREGUNTA 37 5.01.1.019

**37.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Sexualidad humana y sus alteraciones · 5.01.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Sexualidad humana y sus alteraciones. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 1.05.1.002

**38.** **Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A) Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación
B) Primer Episodio de Esquizofrenia; activar Garantía Explícita en Salud (GES N° 34), iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista
C) Trastorno esquizoafectivo; indicar Sertralina 100 mg y reposo en casa
D) Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes
E) Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

PREGUNTA 39 1.05.1.002

**39. Un paciente de 22 años diagnosticado de esquizofrenia inicia tratamiento con Haloperidol 5 mg cada 12 horas por vía oral. A las 24 horas de la primera dosis, es llevado a urgencias por presentar de forma brusca una desviación conjugada y sostenida de la mirada hacia arriba (crisis oculógira), contractura dolorosa intensa del cuello con inclinación lateral (tortícolis) y trismus mandibular. El paciente se encuentra angustiado pero plenamente vigil y afebril. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección inmediato?**

A) Síndrome neuroléptico maligno; administrar dantroleno endovenoso urgente
B) Distonía aguda inducida por antipsicóticos; administrar Biperideno 5 mg intramuscular o endovenoso lento
C) Status epiléptico no convulsivo; administrar fenitoína en infusión rápida
D) Acatisia aguda; prescribir propranolol oral a permanencia
E) Tétanos generalizado; administrar toxoide antitetánico e inmunoglobulina

PREGUNTA 40 1.05.1.002

**40. Un hombre de 26 años con esquizofrenia en tratamiento con Olanzapina 15 mg/día acude a control de salud a los 6 meses de terapia, manteniéndose sin síntomas psicóticos activos. En los exámenes de laboratorio destaca aumento de peso de 9 kg, glicemia en ayunas de 136 mg/dL (confirmada en segunda toma en 132 mg/dL) y triglicéridos en 280 mg/dL. ¿Cuál es la complicación que presenta y la conducta médica indicada?**

A) Hipotiroidismo farmacológico; iniciar levotiroxina 100 mcg al día
B) Síndrome metabólico y diabetes mellitus inducidos por Olanzapina; indicar manejo dietético, metformina y evaluar rotación a un antipsicótico con menor perfil metabólico como Aripiprazol
C) Resistencia a antipsicóticos; duplicar la dosis de Olanzapina a 30 mg al día
D) Suspensión inmediata de todo tratamiento antipsicótico sin reemplazo
E) Insuficiencia suprarrenal secundaria; administrar hidrocortisona endovenosa

PREGUNTA 41 1.05.1.002

**41. Un paciente de 24 años que presentó un primer episodio de esquizofrenia paranoide logra la remisión completa de sus ideas delirantes y alucinaciones tras 6 meses de tratamiento con Risperidona 3 mg/día. Se encuentra asintomático y ha retomado sus actividades cotidianas. Sus familiares preguntan cuánto tiempo debe continuar tomando el antipsicótico. Según las guías clínicas y la evidencia psiquiátrica, ¿cuál es la duración mínima recomendada del tratamiento de mantenimiento?**

A) El medicamento puede suspenderse de inmediato ya que se logró la remisión completa
B) Debe mantenerse durante al menos 1 a 2 años continuos tras la remisión del primer episodio para evitar recaídas
C) Solo debe tomarlo en los días en que vuelva a escuchar voces
D) Debe suspenderse a las 4 semanas y reemplazarse por psicoterapia exclusiva
E) Debe mantenerse por 3 meses y luego usar únicamente benzodiacepinas

PREGUNTA 42 5.01.1.010

**42. Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlo de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno delirante crónico
B) Trastorno de la personalidad esquizoide
C) Delirium
D) Esquizofrenia hebefrénica
E) Trastorno Bipolar

PREGUNTA 43 5.01.1.010

**43. Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de "borregos". Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno del espectro autista en el adulto
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad paranoide (Nota: pregunta añadida a la reconstrucción) RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Instrucciones:

PREGUNTA 44 5.01.1.010

**44. Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno delirante crónico
B) Esquizofrenia
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno de conducta

PREGUNTA 45 1.05.1.002

**45.** **Un paciente de 28 años con esquizofrenia paranoide ha recibido tratamiento con Haloperidol 10 mg/día durante 8 semanas y posteriormente con Risperidona 6 mg/día durante 8 semanas, ambas con adherencia confirmada por sus cuidadores, persistiendo con alucinaciones auditivas agresivas e ideación delirante severa que le impiden salir a la calle. Su hemograma basal muestra leucocitos 6.500/mm³ con neutrófilos en 4.200/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección?**

A) Psicosis reactiva; suspender antipsicóticos e iniciar psicoterapia
B) Esquizofrenia refractaria; iniciar tratamiento con Clozapina bajo protocolo de monitorización hematológica
C) Trastorno bipolar maníaco; iniciar monoterapia con carbamazepina
D) Simulación de síntomas; dar el alta sin medicación
E) Esquizofrenia simple; rotar a Clorpromazina en dosis bajas

PREGUNTA 46 1.05.1.002

**46.** **Un paciente de 34 años con esquizofrenia refractaria en tratamiento con Clozapina 300 mg/día acude a su control en la semana 10 de terapia. Su hemograma de control protocolizado muestra leucocitos totales de 2.200/mm³ y Recuento Absoluto de Neutrófilos (RAN) de 790/mm³. El paciente no presenta fiebre ni síntomas infecciosos. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A) Reducir la dosis de Clozapina a 150 mg al día y repetir el hemograma en un mes
B) Suspender de inmediato la Clozapina, hospitalizar en aislamiento protector y contraindicar la reexposición de por vida
C) Mantener la Clozapina e indicar amoxicilina profiláctica por vía oral
D) Asociar Biperideno 5 mg cada 12 horas para estimular la médula ósea
E) Asumir error de laboratorio, tranquilizar al paciente y mantener la dosis

PREGUNTA 47 1.13.1.004

**47.** **Una mujer de 32 años sufrió un accidente automovilístico grave hace 3 semanas en el cual falleció su acompañante. Desde hace 10 días presenta insomnio, llanto frecuente, sobresaltos intensos ante ruidos de motores y recuerdos intrusivos involuntarios del choque. Niega antecedentes psiquiátricos previos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado en este momento?**

A) Trastorno de Estrés Postraumático crónico
B) Trastorno de Estrés Agudo
C) Esquizofrenia paranoide reactiva
D) Trastorno de pánico primario
E) Trastorno somatomorfo indiferenciado

PREGUNTA 48 1.13.1.004

**48.** **Un hombre de 40 años diagnosticado de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) tras haber sido víctima de secuestro hace 6 meses recibe tratamiento con Sertralina 100 mg/día y TCC. Si bien ha mejorado en su reactividad general durante el día, persiste con pesadillas aterradoras recurrentes en las que revive el encierro, despertando con diaforesis profusa y taquicardia todas las noches. ¿Cuál es el fármaco adyuvante con mayor evidencia específica para el control de las pesadillas en el TEPT?**

A) Prazosina
B) Diazepam
C) Haloperidol
D) Litio
E) Metilfenidato

PREGUNTA 49 5.01.1.005

**49.** **Paciente que presenció un asalto hace 2 semanas, ahora con angustia, irritabilidad, insomnio y estado de hiperalerta. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
B) Trastorno adaptativo con ansiedad
C) Trastorno por estrés agudo
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno depresivo mayor

PREGUNTA 50 5.01.1.006

**50.** **Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno por estrés post traumático
B) Trastorno de ansiedad
C) Trastorno evitativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno adaptativo

PREGUNTA 51 5.01.1.006

**51.** **Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Depresión reactiva
D) Depresión psicótica
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 52 5.01.1.006

**52.** **Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático**

A) benzodiazepinas
B) ISRS
C) Triciclicos
D) Antipsicoticos tipicos
E) Antipsicóticos atípicos

PREGUNTA 53 5.01.1.006

**53.** **Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno de estrés postraumático

PREGUNTA 54 5.01.1.006

**54.** **Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno agudo por estrés
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Trastorno de angustia generalizada
E) Trastorno de angustia social

## BLOQUE 4 TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

PREGUNTA 55 5.01.1.026

**55.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Enuresis · 5.01.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enuresis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 4.01.1.001

**56.** **Una mujer de 48 años, ingeniera en sistemas con excelente desempeño laboral, acude al cuartel de policía y posteriormente a la posta médica denunciando que sus vecinos de departamento han taladrado microscópicamente el piso para introducir gas tóxico que le causa ardor en la piel al dormir. Al examen mental se presenta pulcra, colaboradora, con discurso fluido y coherente, sin alteraciones del lenguaje ni síntomas negativos, y niega escuchar voces. El cuadro lleva 4 meses de evolución sin deterioro en otras áreas de su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia paranoide avanzada
B) Trastorno Delirante Crónico tipo persecutorio/somático
C) Trastorno psicótico breve reactivo
D) Demencia frontotemporal incipiente
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 57 4.01.1.001

**57.** **Un comerciante de 38 años sin antecedentes psiquiátricos pierde su local comercial en un incendio intencional. A los dos días comienza con agitación psicomotora, insomnio total, llanto incontrolable y afirmaciones de que "ve demonios que le ordenan caminar en círculos". Es hospitalizado y tratado transitoriamente con dosis bajas de Risperidona. Al día 18 del cuadro, los síntomas psicóticos desaparecen por completo, encontrándose orientado, reflexivo y reincorporándose plenamente a sus actividades comerciales. ¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo?**

A) Esquizofrenia hebefrénica
B) Trastorno Psicótico Breve con desencadenante grave
C) Trastorno esquizofreniforme residual
D) Trastorno de personalidad límite
E) Trastorno bipolar en manía pura

PREGUNTA 58 1.13.2.001

**58.** **Un paciente de 29 años con esquizofrenia en tratamiento hospitalario con Haloperidol 15 mg/día presenta fiebre de 39.5 °C, diaforesis profusa, presión arterial fluctuante entre 160/100 y 90/60 mmHg, taquicardia de 125 lpm y estupor. Al examen físico destaca rigidez muscular generalizada en caño de plomo. El laboratorio urgente informa leucocitos de 21.000/mm³ y CPK en 14.200 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la primera medida que debe implementarse?**

A) Meningitis bacteriana aguda; iniciar Ceftriaxona y Vancomicina manteniendo el antipsicótico
B) Síndrome Neuroléptico Maligno; suspender de inmediato el Haloperidol e iniciar hidratación endovenosa masiva y traslado a UPC
C) Distonía laríngea aguda; administrar Biperideno 5 mg intramuscular
D) Síndrome serotoninérgico; administrar Ciproheptadina oral exclusiva
E) Catatonía periódica benigna; aumentar la dosis de Haloperidol a 30 mg al día

PREGUNTA 59 1.13.2.001

**59.** **Un paciente de 35 años que consume Paroxetina 40 mg/día por depresión acude a urgencias tras ingerir 200 mg de Tramadol por un lumbago agudo. A las pocas horas presenta agitación psicomotora, diarrea acuosa profusa, temblor y fiebre de 38.6 °C. Al examen físico destaca midriasis bilateral reactiva, taquicardia de 120 lpm, hiperreflexia osteotendinosa patológica generalizada (4+) y clonus inducible en ambos tobillos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial correcto frente al síndrome neuroléptico maligno?**

A) Síndrome Neuroléptico Maligno; cursa con clonus e hiperreflexia
B) Síndrome Serotoninérgico; caracterizado por la presencia distintiva de hiperreflexia, clonus y diarrea por exceso de serotonina
C) Intoxicación colinérgica por organofosforados
D) Tétanos generalizado cefálico
E) Crisis tirotóxica aguda

PREGUNTA 60 1.13.2.001

**60.** **¿Cuál es el objetivo fisiopatológico fundamental de la hidratación endovenosa masiva con solución fisiológica en el manejo de un paciente con Síndrome Neuroléptico Maligno y CPK de 22.000 UI/L?**

A) Aumentar la litemia plasmática para estabilizar el ánimo
B) Garantizar una diuresis forzada de 2 a 3 mL/kg/hora para prevenir la necrosis tubular aguda y la falla renal por mioglobinuria
C) Inducir hiponatremia dilucional para frenar las contracciones musculares
D) Disminuir la presión intracraneana mediante hemodilución osmótica
E) Favorecer la excreción hepática del antipsicótico vía biliar

PREGUNTA 61 1.13.2.001

**61.** **Un paciente ingresado en la UCI con diagnóstico de Síndrome Neuroléptico Maligno grave persiste con temperatura de 40.2 °C y rigidez generalizada severa a pesar de 6 horas de suspensión de neurolépticos, enfriamiento físico e hidratación intensa. Se decide iniciar farmacoterapia específica de rescate. ¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos es el indicado en esta situación?**

A) Dantroleno sódico endovenoso y/o Bromocriptina por sonda nasogástrica
B) Flumazenil endovenoso en bolo continuo
C) Naloxona subcutánea seriada
D) Haloperidol en infusión continua de baja dosis
E) Ciproheptadina oral exclusiva

PREGUNTA 62 1.09.2.001

**62.** **Un hombre de 24 años con esquizofrenia paranoide descompensada ingresa a urgencias en estado de extrema agitación psicomotora, amenazando físicamente al equipo médico y arrojando mobiliario. Tras fracasar la contención verbal, se decide realizar contención física mecánica transitoria y administrar fármacos parenterales de rescate. ¿Cuál es la combinación farmacológica intramuscular más segura, eficaz y recomendada para el control rápido de la agitación en urgencias?**

A) Haloperidol 5 mg IM asociado a Lorazepam 2 mg IM
B) Olanzapina 10 mg IM asociada a Lorazepam 4 mg IM en la misma jeringa
C) Morfina 10 mg IM asociada a Diazepam 10 mg IM
D) Fenobarbital 200 mg IM en monoterapia
E) Biperideno 10 mg IM asociado a Clorpromazina 100 mg EV directo

PREGUNTA 63 1.09.2.001

**63. Un anciano de 82 años hospitalizado en medicina interna al segundo día postoperatorio de fractura de cadera presenta bruscamente en horas de la noche agitación, desorientación témporo-espacial, alucinaciones visuales viendo animales en el techo e intentos reiterados de arrancarse la vía venosa y la sonda Foley. Sus signos vitales son estables y el hemoglucotest es de 110 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el manejo farmacológico de elección en caso de requerir sedación?**

A) Crisis de angustia; administrar Alprazolam 2 mg sublingual
B) Delirium hiperactivo orgánico; buscar y corregir la causa desencadenante y usar Haloperidol a dosis bajas (0.5 a 1 mg VO/IM) si hay riesgo físico
C) Debut de esquizofrenia tardía; iniciar Risperidona 6 mg al día
D) Demencia tipo Alzheimer; prescribir Memantina en bolo
E) Trastorno adaptativo; indicar reposo y contención mecánica sin medicamentos

PREGUNTA 64 1.09.2.001

**64. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de psicofármacos parenterales está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en el servicio de urgencias por asociarse a un alto riesgo de colapso cardiorrespiratorio fatal e hipotensión severa refractaria?**

A) Haloperidol IM asociado a Lorazepam IM
B) Olanzapina IM coadministrada de forma simultánea con Lorazepam IM
C) Haloperidol IM asociado a Biperideno IM
D) Clorpromazina VO asociada a Diazepam VO
E) Risperidona VO asociada a Clonazepam VO

PREGUNTA 65 1.09.2.001

**65. Respecto a la contención física mecánica de cuatro extremidades en un paciente con agitación psicomotora violenta que no respondió a contención verbal ni farmacológica, ¿cuál es una exigencia legal y clínica obligatoria según la Ley N° 21.331 de salud mental en Chile?**

A) La indicación puede ser verbal y no requiere ser registrada en la ficha clínica
B) Debe existir una indicación médica explícita registrada por escrito en la ficha clínica, detallando la justificación, y se debe supervisar y registrar la condición del paciente cada 15 a 30 minutos
C) El paciente debe ser dejado en posición prono (boca abajo) para evitar que muerda al personal
D) La sujeción mecánica debe mantenerse fija por un período mínimo obligatorio de 24 horas ininterrumpidas
E) Las sujeciones deben atarse directamente a las barandas laterales móviles de la camilla

PREGUNTA 66 5.01.2.002

**66. Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
B) Risperidona 1 mg vía oral
C) Diazepam 5 mg intramucular
D) Contención verbal
E) Contención física

PREGUNTA 67 1.09.1.001

**67. Un hombre de 52 años en situación de calle con antecedente de alcoholismo crónico severo y desnutrición extrema es llevado a urgencias por compromiso de conciencia progresivo. Al examen físico destaca sopor profundo, nistagmo bilateral horizontal y ataxia de tronco que le impide la bipedestación. La glicemia capilar informa 48 mg/dL. ¿Cuál es la secuencia farmacológica obligatoria que debe administrarse de inmediato?**

A) Administrar 4 ampollas de suero glucosado al 30% EV en bolo rápido y luego evaluar vitaminas
B) Administrar Tiamina 100 mg endovenosa o intramuscular previo o simultáneo a la infusión de suero glucosado
C) Administrar Fenitoína 1 g en infusión endovenosa rápida
D) Administrar Naloxona 0.4 mg EV y Flumazenil 0.5 mg EV directo
E) Administrar Insulina cristalina 10 UI subcutáneas

PREGUNTA 68 1.09.1.001

**68. Un hombre de 45 años con antecedente de cirrosis hepática Child-Pugh B por alcoholismo crónico ingresa a urgencias por un síndrome de abstinencia alcohólica moderado a severo (CIWA-Ar de 18 puntos) con temblor marcado, náuseas, diaforesis y ansiedad extrema tras 24 horas del cese de ingesta. ¿Cuál es la benzodiacepina de elección para tratar la abstinencia en este paciente con daño hepático demostrado?**

A) Diazepam
B) Lorazepam
C) Clordiazepóxido
D) Alprazolam
E) Midazolam

PREGUNTA 69 1.09.1.001

**69. Un paciente alcohólico de 42 años consulta en urgencias a las 18 horas de su último trago refiriendo escuchar voces de personas desconocidas que murmuran amenazas a través de la pared del baño. En el examen mental se constata vigil, perfectamente orientado en tiempo y espacio (sabe la fecha exacta y dónde está), con atención preservada y juicio parcialmente conservado, reconociendo que las voces podrían deberse a haber dejado el trago. El examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Delirium Tremens
B) Alucinosis Alcohólica
C) Esquizofrenia paranoide de inicio tardío
D) Encefalopatía hepática grado IV
E) Demencia de Korsakoff

PREGUNTA 70 5.01.1.012

**70. Un paciente de 70 años, con antecedente de daño hepá8co crónico y consumo de alcohol ac8vo, consulta porque quiere dejar de beber. Consume 3 litros de cerveza al día y comenta que hace un año intentó bajar el consumo a 1 litro al día, sin embargo, presentó agitación, angus8a y la visualización de insectos que él no sabía que no eran reales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar el cese inmediato del consumo de alcohol
B) Iniciar disulfiram
C) Hospitalizar para desintoxicación
D) Indicar lorazepam
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

PREGUNTA 71 5.01.1.014

**71. Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?**

A) Tiamina
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Clorpromazina
E) Risperidona

PREGUNTA 72 5.01.1.025

**72. [ATENCIÓN PRIMARIA: Retardo mental · 5.01.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retardo mental. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

## BLOQUE 5 ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

PREGUNTA 73 5.01.1.027

**73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Encopresis · 5.01.1.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Encopresis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 74 5.01.1.011

**74. Una paciente de 35 años es traída al servicio de urgencia debido a que, luego del consumo de alcohol en una fiesta, presentó una ac8tud agresiva peleando con otros invitados, a quienes arrojó vasos de vidrio, por lo que fue re8rada del lugar. Refiere que consume alcohol de manera esporádica, habitualmente solo durante los fines de semana, y que lo hace como una forma de distenderse de su alta carga laboral. En una oportunidad fue detenida por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, ella no considera que ello sea un problema. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar disulfiram vía oral
B) Indicar benzodiacepinas vía oral
C) Iniciar bupropión vía oral
D) Realizar entrevista mo2vacional
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

PREGUNTA 75 5.01.1.011

**75. Un hombre de 24 años consulta en urgencias por dolor precordial opresivo de 30 minutos de evolución tras haber consumido cocaína. Al ingreso destaca muy angustiado, sudoroso, con midriasis bilateral reactiva, PA 195/110 mmHg y FC 130 lpm. El ECG muestra taquicardia sinusal e infradesnivel del ST de 1.5 mm en cara anterolateral. ¿Cuál de los siguientes fármacos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en este paciente?**

A) Diazepam endovenoso
B) Nitroglicerina sublingual
C) Propranolol endovenoso
D) Ácido Acetilsalicílico oral
E) Lorazepam endovenoso

PREGUNTA 76 5.01.1.011

**76. Una mujer de 65 años con antecedente de insomnio crónico en tratamiento regular con Clonazepam 2 mg diario desde hace 10 años es traída a urgencias en sopor profundo tras ingerir accidentalmente una dosis triple de su medicación junto con una copa de vino. Sus signos vitales son estables (PA 115/70 mmHg, FC 72 lpm, SatO2 97% ambiental) y no presenta compromiso hemodinámico ni apnea. El médico de turno evalúa administrar Flumazenil endovenoso para revertir el sopor. ¿Por qué está desaconsejado o contraindicado el uso de Flumazenil en este escenario?**

A) Porque el flumazenil carece de acción sobre los receptores de clonazepam
B) Porque en usuarios crónicos de benzodiacepinas el flumazenil precipita un síndrome de abstinencia agudo severo con alto riesgo de status epiléptico refractario mortal
C) Porque el flumazenil produce hiperpotasemia fulminante
D) Porque está reservado exclusivamente para sobredosis de morfina y opioides
E) Porque aumenta la presión intraocular de forma irreversible

PREGUNTA 77 5.01.2.003

**77.** Un hombre encuentra a su pareja en su casa desorientada y con una ac8tud agresiva y agitada, por lo que la lleva al servicio de urgencia. Al examen Fsico presenta sudoración profusa y sus signos vitales muestran presión arterial 170/110 mmHg, frecuencia cardíaca 160 por minuto y temperatura 38,1 °C. En el examen neurológico se aprecia desorientada en 8empo y espacio, con agitación psicomotora y pupilas midriá8cas isocóricas. ¿Qué sustancia ingirió con mayor probabilidad?

A) Barbitúricos
B) Canabinoides
C) Anfetaminas
D) Órganofosforados
E) Opiáceos

PREGUNTA 78 1.09.1.001

**78.** Un hombre de 34 años, soltero, informático que realiza teletrabajo en horario nocturno, es derivado por salud laboral. Vive completamente solo, no tiene amigos y refiere: "No me interesa compartir con nadie, me siento mucho más cómodo así; los elogios o reproches de mi jefe me dan exactamente lo mismo". No presenta ideas delirantes, alucinaciones ni síntomas afectivos. Su discurso es coherente pero con notable frialdad emocional. ¿Cuál es el diagnóstico de personalidad más probable?

A) Trastorno de personalidad por evitación
B) Trastorno de personalidad esquizoide
C) Trastorno de personalidad esquizotípico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Fobia social grave

PREGUNTA 79 1.09.1.001

**79.** Una joven de 20 años acude al servicio de urgencias traída por su madre tras cortarse los antebrazos superficialmente con un bisturí escolar. La madre refiere que la paciente pasa de la risa al llanto en cuestión de horas, gasta dinero impulsivamente, tiene un miedo pánico a quedarse sola y con frecuencia acusa a sus familiares de "no quererla". ¿Cuál es el abordaje psicoterapéutico que cuenta con mayor respaldo de evidencia científica para este cuadro?

A) Terapia Electroconvulsiva bilateral
B) Terapia Dialéctico-Conductual (DBT)
C) Psicoanálisis clásico exclusivo
D) Hipnosis clínica regresiva
E) Terapia de relajación pasiva exclusiva

PREGUNTA 80 5.01.1.016

**80.** Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno límite de la personalidad
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno delirante
E) Trastorno depresivo mayor

PREGUNTA 81 5.01.1.016

**81.** Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de dos intoxicaciones medicamentosas y autoagresiónes. Además estuvo en tratamiento por bulimia hace un año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío. Además es impulsiva en el consumo de alcohol y compras. ¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

A) Histriónico
B) Limítrofe
C) Narcisista
D) Antisocial
E) Dependiente

PREGUNTA 82 5.01.1.016

**82.** Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno adaptativo

PREGUNTA 83 5.01.1.016

**83.** Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno bipolar
D) Distimia
E) Depresión mayor

PREGUNTA 84 5.01.1.016

**84.** Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras peronsonas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de personalidad dependiente
C) Fobia social
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

PREGUNTA 85 5.01.1.016

**85. Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno evitativo de la personalidad
B) Síndrome de Asperger
C) Depresión mayor
D) Distimia
E) Fobia social

PREGUNTA 86 4.01.1.001

**86. Un niño de 8 años es traído a consulta médica porque su profesora señala que se para constantemente de su asiento en clases, habla sin parar, interrumpe a sus compañeros y no termina las guías escolares por distraerse con cualquier estímulo. Los padres relatan que en la casa el niño presenta la misma conducta desde los 5 años: no logra mantenerse sentado a la mesa, pierde constantemente los lápices y cuadernos, y le cuesta seguir instrucciones de más de un paso. Su coeficiente intelectual y examen neurológico son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco de primera línea?**

A) Trastorno del espectro autista; iniciar Risperidona
B) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); tratamiento farmacológico de primera línea con Metilfenidato asociado a intervenciones psicopedagógicas
C) Trastorno bipolar maníaco precoz; iniciar Carbonato de Litio
D) Trastorno oposicionista desafiante puro; internación en centro psiquiátrico
E) Depresión infantil enmascarada; indicar Sertralina

PREGUNTA 87 4.01.1.001

**87. Una adolescente de 16 años consulta traída por su colegio debido a emaciación progresiva. Al examen físico destaca con IMC de 13.5 kg/m², hipotermia de 35.0 °C, presión arterial de 75/45 mmHg y frecuencia cardíaca de 34 lpm en reposo. Se constata lanugo en espalda y abdomen escafoide. La paciente rechaza tener problemas y afirma que solo desea "bajar un par de kilos más". ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A) Indicar dieta hipercalórica fraccionada y citar a control en un mes en policlínico
B) Hospitalización médica inmediata en unidad de cuidados intensivos/intermedios para monitorización cardíaca y realimentación lenta controlada
C) Prescribir Fluoxetina 60 mg al día por vía oral y dar el alta a su domicilio
D) Derivar a psicoterapia psicoanalítica ambulatoria semanal
E) Indicar Metilfenidato matinal para mejorar su motivación de alimentarse

PREGUNTA 88 5.01.1.018

**88. Una paciente de 17 años es traída por su padre, quien se muestra muy preocupado porque la considera muy delgada y siente que come muy poco. Relata que solo come una fracción del plato que se sirve en su casa y que deja gran parte de la comida que se le envía al colegio. La paciente comenta que la mayoría de sus compañeras son igualmente delgadas y no considera que tenga un problema, más allá de mostrarse molesta por la insistencia de su padre en consultar. Su IMC es de 16 kg/m². ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Trastorno obsesivo de la personalidad
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Dismorfofobia
E) Sana

PREGUNTA 89 5.01.1.030

**89. [ATENCIÓN PRIMARIA: Trastorno conducta oposicionista desafiante · 5.01.1.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Trastorno conducta oposicionista desafiante. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 90 5.01.1.031

**90. Adolescente de 14 años que presenta ausencias repetidas al colegio, peleas con compañeros, robos dentro del hogar y consumo de alcohol desde los 12 años. Los padres refieren que "no respeta ninguna norma". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Discapacidad intelectual
B) TDAH
C) Trastorno de conducta
D) Trastorno del espectro autista
E) Fobia social

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

**Dependencia de otras drogas**

5.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

### PREGUNTA 2 Respuesta: C

**Intento de suicidio en niños y adolescentes**

5.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 87). Evalúa el manejo clínico de Intento de suicidio en niños y adolescentes según directrices MINSAL vigentes.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta un episodio depresivo mayor moderadamente grave cubierto por el GES N° 21. La indicación correcta de primera línea es un ISRS como Sertralina 50 mg/día por la mañana, acompañado de psicoterapia, educación al paciente sobre el período de latencia terapéutica (2-4 semanas) y control en 2 semanas para supervisar adherencia y tolerancia. El distractor A es erróneo porque las benzodiacepinas no tienen acción antidepresiva y generan dependencia. El distractor C es incorrecto porque no hay ideación suicida activa ni síntomas psicóticos que justifiquen hospitalización o TEC. El distractor D posterga injustificadamente el tratamiento normado. El distractor E usa dosis tóxicas de tricíclicos y antipsicóticos innecesarios. Perla de examen: Todo inicio de ISRS en APS debe acompañarse de educación sobre la latencia de respuesta para evitar el abandono prematuro por parte del paciente.

### PREGUNTA 4 Respuesta: D

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

5.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene un trastorno adaptativo clásico de tipo ansioso (gatillante claro y síntomas ansiosos). Si bien tiene síntomas somáticos (cefalea tensional) no es un trastorno de somatización (múltiples síntomas de todo tipo).

### PREGUNTA 5 Respuesta: B

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

5.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Depresión: La depresión se trata preferentemente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la sertralina. La depresión atípica, por otro lado, presenta síntomas como aumento de peso e hipersomnia y tradicionalmente se trataba con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) como la fenelzina, pero, en la actualidad, los ISRS también se recomiendan como tratamiento de primera línea para la depresión atípica. En este caso es típica, al haber insomnio, en lugar de hipersomnia.

### PREGUNTA 6 Respuesta: B

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

5.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tratamiento de la Depresión: El tratamiento de elección para un episodio depresivo mayor unipolar son los antidepresivos ISRS, especialmente si el paciente ya ha respondido a este tipo de medicamento. Si no hay respuesta después de 4 semanas, se recomienda cambiar a un antidepresivo dual como venlafaxina o duloxetina.

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A**

5.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastornos neurocognitivos" (5.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

5.01.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: E**

5.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Es una amnesia disociativa clásica.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

5.01.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Tiene un trastorno facticio clásico, del tipo Múnchausen, ya que se autoprovoca síntomas (no solo los finge). No tiene ganancias económicas (así que no es simulación, sino facticio, cuya ganancia es afectiva, aunque no se muestre en la pregunta).

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: D**

5.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Es un TEA clásico del adulto, con rigidez cognitiva, intereses restringidos, alteraciones sociales, estereotipias más escasa autorregulación, seguramente por estar mal manejado.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

5.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno específico del aprendizaje escolar" (5.01.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: D**

5.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Es un TDAH clásico, de alta capacidad (logró ser ingeniera). Se maneja con técnicas de trabajo y, en algunos casos, fármacos estimulantes como el meGlfenidato y anfetaminas (ej. lisdexanfetamina).

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

5.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno somatización en niños" (5.01.1.032), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: A**

5.01.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastornos ansiosos en niños" (5.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

5.01.1.034 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

Depresión en Adolescentes: El cuadro clínico corresponde a una depresión o episodio depresivo mayor. La distimia se diagnostica en adolescentes tras un año de ánimo bajo y disforia sin cumplir criterios de depresión. En este caso, sí hay criterios de depresión porque se afecta el peso, el sueño, el rendimiento escolar y la vida social.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

5.01.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Conducta suicida" como urgencia clínica (5.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: A**

5.01.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES**

Episodios depresivos previos + episodio maníaco actual (grandiosidad, insomnio, gastos impulsivos, euforia) = trastorno bipolar tipo I. Un episodio maníaco es suficiente para el diagnóstico.

---

## BLOQUE 2 TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: B** **Disfunción sexual**

5.01.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Dispareunia Superficial: La dispareunia superficial, también conocida como vaginismo o síndrome de dolor genitopélvico penetración, se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Es importante diferenciarla del trastorno orgásmico femenino (ausencia de orgasmo) y el trastorno del deseo sexual hipoactivo (disminución del deseo sexual), que no presentan dolor.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: D**

5.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

**Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes**

Pregunta difícil.

**PREGUNTA 21** **Respuesta: B**

1.11.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo**

El paciente presenta una reacción emocional desadaptativa temporal ante un estresor biográfico claro (ruptura amorosa hace 6 semanas). Los síntomas llevan 4 semanas (< 3 meses de inicio), causan malestar pero no cumplen los 5 criterios exigidos para un Episodio Depresivo Mayor (mantiene apetito, reactividad afectiva y capacidad de actividad física). Corresponde a un Trastorno Adaptativo. El manejo correcto en atención primaria es la psicoterapia breve y consejería para elaboración del duelo vincular, sin indicación de antidepresivos (A) ni benzodiacepinas crónicas (C). La distimia (D) requiere al menos 2 años de evolución continua. Perla de examen: En trastorno adaptativo reactivo a un estresor identificable, la psicoterapia es el tratamiento angular y no se indican antidepresivos de entrada.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: B**

1.11.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo**

El cuadro de ánimo depresivo crónico, baja energía, baja autoestima y anhedonia leve a moderada de curso continuo durante más de 10 años, sin períodos asintomáticos superiores a 2 meses, cumple con precisión los criterios diagnósticos del Trastorno Depresivo Persistente (Distimia). A diferencia de la creencia tradicional de que la distimia solo responde a psicoterapia, la evidencia actual demuestra que el tratamiento óptimo es la combinación de un ISRS (como Sertralina o Escitalopram) a dosis plenas durante períodos prolongados asociado a psicoterapia cognitivo-conductual estructurada. El trastorno adaptativo (A) requiere un estresor reciente (< 3 meses) y dura menos de 6 meses. La personalidad esquizoide (C) no presenta ánimo depresivo ni sufrimiento egodistónico. Perla de examen: La distimia exige al menos 2 años de síntomas continuos en adultos y se beneficia significativamente de la combinación de ISRS y psicoterapia.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

La paciente presenta un Trastorno de Pánico con agorafobia incipiente. El tratamiento farmacológico de elección y primera línea a largo plazo son los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) como Sertralina, iniciando a dosis bajas (25 mg/día) para minimizar la exacerbación inicial de ansiedad, asociada a Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Las benzodiacepinas se utilizan únicamente como puente transitorio (primeras 2-4 semanas) mientras se instala el efecto terapéutico del ISRS. El distractor A comete el error grave de perpetuar benzodiacepinas en monoterapia, lo que genera adicción y rebote. El distractor C usa betabloqueadores que controlan la taquicardia periférica pero no tratan el trastorno de pánico central. El distractor D usa antipsicóticos típicos innecesarios. Perla de examen: En trastorno de pánico, los ISRS a titulación lenta son la base del tratamiento definitivo, reservando las benzodiacepinas como rescate inicial acotado.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

El manejo de la crisis de angustia aguda en el servicio de urgencias se basa en medidas no farmacológicas iniciales: ubicar al paciente en un entorno tranquilo, brindar contención verbal asegurando que no se encuentra en peligro vital y reeducar el patrón respiratorio para frenar la hiperventilación diafragmática. Si la ansiedad persiste elevada, se indica una benzodiacepina de acción rápida y absorción sublingual u oral como Clonazepam 0.5-1 mg o Lorazepam 1 mg. La adenosina (A) es para taquicardias paroxísticas supraventriculares, no para taquicardia sinusal por pánico. La morfina (D) está contraindicada. Respirar en bolsa plástica cerrada (E) está obsoleto y proscrito porque puede causar hipoxia severa y arritmias. Perla de examen: La contención verbal empática y las benzodiacepinas orales/sublinguales constituyen el pilar de rescate en la crisis de pánico aguda.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

Al iniciar un ISRS en pacientes con trastorno de pánico, el incremento agudo de serotonina en la corteza y amígdala estimula de forma precoz receptores postsinápticos 5-HT2A y 5-HT2C antes de que ocurra la desensibilización de autorreceptores, lo que desencadena un aumento paradójico transitorio de ansiedad, temblor y taquicardia en los primeros 5 a 10 días. La conducta correcta es anticipar este fenómeno, educar al paciente para que no abandone la terapia, disminuir la dosis a la mitad temporalmente (10 mg de fluoxetina o 25 mg de sertralina) y usar una benzodiacepina a dosis baja como puente sintomático durante las primeras semanas. Duplicar la dosis (E) exacerbaría el cuadro. Perla de examen: En trastorno de pánico, los ISRS deben iniciarse siempre a mitad de dosis para evitar el síndrome de aumento paradójico de ansiedad.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

1.03.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

La paciente presenta Agorafobia, definida por el miedo intenso y evitación de situaciones donde escapar pueda ser difícil o la ayuda inaccesible en caso de desarrollar síntomas tipo pánico (transporte, multitudes, salir sola de casa). La psicoterapia con mayor nivel de evidencia científica (Nivel IA) para la agorafobia es la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), específicamente mediante desensibilización sistemática con técnicas de exposición en vivo gradual a las situaciones temidas y exposición interoceptiva a las sensaciones corporales. El distractor A confunde la evitación fóbica con delirios. El distractor D confunde agorafobia con fobia social (en la fobia social el miedo es al escrutinio y juicio negativo de los demás, no a quedar atrapado o morir). Perla de examen: La TCC con técnicas de exposición en vivo e interoceptiva es la psicoterapia de elección en agorafobia.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

Tiene un trastorno de pánico o trastorno de ansiedad o de angustia clásico: crisis de pánico recurrentes e inexplicadas. Que ya no salga de su casa sugiere que, además, tiene agorafobia, pero predomina el diagnóstico de TP.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

Tiene crisis de pánico recurrentes, por lo que es un trastorno de angustia o trastorno de pánico. El miedo a salir de su casa probablemente sea porque es "con agorafobia". El tratamiento de los trastornos ansiosos suele ser con antidepresivos IRS. Las benzodiacepinas sirven como tratamiento sintomático, pero el IRS es el tratamiento principal.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: E**

5.01.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

**Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS**

Tuvo una crisis de pánico y, por recurrir, ahora tiene un trastorno de pánico (o de angustia o de ansiedad), que se trata con IRS (se pueden agregar BDZ, ejemplo alprazolam c/8 horas al inicio y luego SOS, pero solo como tratamiento sintomático). No confundir con trastorno de ansiedad generalizada, aunque el tratamiento es el mismo.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social**

El cuadro cumple con los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG): preocupación excesiva e incontrolable sobre múltiples ámbitos de la vida diaria presente durante más de 6 meses (8 meses en el caso), asociada a tensión muscular, irritabilidad e insomnio. El tratamiento de elección y primera línea avalado por la evidencia son los ISRS (Escitalopram 10-20 mg/día o Sertralina 50-100 mg/día) o IRSN (Venlafaxina) combinados con Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Las benzodiacepinas a demanda (A) no tratan la patología de base y conllevan riesgo adictivo. No hay síntomas psicóticos (D). El Propranolol (E) no es el tratamiento de mantenimiento del TAG. Perla de examen: El criterio temporal del TAG es de al menos 6 meses y su tratamiento de 1.ª línea son los ISRS.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

1.09.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social**

El cuadro corresponde a un Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social) en su subtipo circunscrito o de actuación en público (pánico escénico). Al no existir un trastorno de ansiedad generalizado en la vida diaria, no está indicado el uso de antidepresivos continuos a largo plazo. La indicación farmacológica de elección y alta rentabilidad para este escenario en el EUNACOM es un betabloqueador no cardioselectivo: Propranolol 10 a 40 mg vía oral tomado 30 a 60 minutos antes de la exposición. El fármaco bloquea los receptores adrenérgicos periféricos suprimiendo el temblor, la taquicardia y el rubor sin alterar la claridad cognitiva. Perla de examen: En fobia social de actuación circunscrita a hablar en público, el Propranolol administrado 1 hora antes es el tratamiento de rescate de elección.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

5.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social**

Fobia social / trastorno de ansiedad social: el tratamiento farmacológico de primera línea son los ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina). Se combinan con TCC. El propranolol es para situaciones puntuales.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: E**

5.01.1.036 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social**

Tiene distinas preocupaciones, de distintos tipos, por lo que es un TAG clásico.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS**

El paciente presenta un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) con obsesiones de duda/daño y compulsiones de comprobación. El cuadro es nítidamente egodistónico (el paciente reconoce que es absurdo e intenta no hacerlo, pero la angustia lo doblega), lo que excluye el trastorno de personalidad anancástico/TPOC (A). La psicoterapia con mayor grado de recomendación y evidencia científica en TOC es la Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición con Prevención de Respuesta (EPR), en la cual se expone al paciente al estímulo que gatilla la obsesión impidiendo la ejecución del ritual de comprobación. No hay psicosis (C y D). Perla de examen: En el TOC la clínica es egodistónica y la psicoterapia obligada es la Exposición con Prevención de Respuesta.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS**

Una de las particularidades farmacológicas fundamentales del TOC en el EUNACOM es que la respuesta terapéutica exige dosis significativamente mayores de ISRS que las empleadas en la depresión mayor (ej. Fluoxetina 60-80 mg/día, Sertralina 200 mg/día) y un período de latencia sustancialmente más prolongado (8 a 12 semanas para alcanzar la meseta terapéutica). Evaluar la respuesta a las 4 semanas con dosis baja (20 mg de fluoxetina) es un error metodológico. La conducta correcta es educar al paciente, titular progresivamente la dosis hacia el rango máximo tolerado y esperar el tiempo normado antes de rotar de fármaco. Perla de examen: En el TOC los ISRS requieren dosis altas y un período de evaluación mínimo de 8 a 12 semanas.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: E**

5.01.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS**

TOC de libro

---

## BLOQUE 3 TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

5.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Sexualidad humana y sus alteraciones**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Sexualidad humana y sus alteraciones" (5.01.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

El paciente cumple criterios DSM-5 para Esquizofrenia: síntomas positivos (delirios de persecución, alucinaciones auditivas comentadoras), síntomas negativos (aplanamiento afectivo, abulia) y disfunción sociolaboral grave de más de 6 meses de duración en un adulto joven con tóxicos negativos. En Chile, este cuadro constituye un Primer Episodio de Esquizofrenia cubierto por la Garantía GES N° 34, que garantiza confirmación diagnóstica por psiquiatra en ≤ 20 días y tratamiento integral en ≤ 24 horas desde la confirmación. La conducta correcta es notificar el caso GES, iniciar un antipsicótico atípico de primera línea (ej. Risperidona u Olanzapina) y derivar a nivel secundario. El trastorno psicótico breve (D) dura menos de un mes. Perla de examen: En Chile, todo primer episodio de esquizofrenia en mayores de 15 años debe notificarse e ingresar por GES N° 34.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

El cuadro corresponde a una Distonía Aguda, reacción adversa extrapiramidal precoz (habitualmente en las primeras 24 a 48 horas tras iniciar o aumentar la dosis de un antipsicótico de alta potencia como Haloperidol). Se produce por un bloqueo dopaminérgico agudo que genera un predominio colinérgico relativo en los ganglios basales, manifestándose como contracciones musculares tónicas dolorosas e involuntarias (crisis oculógiras, tortícolis espasmódica, trismus). El tratamiento de rescate inmediato y específico es un anticolinérgico de acción central: Biperideno 5 mg IM o EV lento, con resolución de los síntomas en 10 a 20 minutos. El SNM (A) cursa con hipertermia grave, rigidez en tubo de plomo y disautonomía. Perla de examen: La distonía aguda por antipsicóticos es precoz y se trata de urgencia con Biperideno parenteral.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

La Olanzapina (junto con la Clozapina) es el antipsicótico con mayor riesgo de síndrome metabólico, provocando ganancia ponderal masiva, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina y debut de Diabetes Mellitus tipo 2. La conducta médica integral ante este hallazgo consiste en: 1) Diagnosticar y tratar la diabetes mellitus y dislipidemia con cambios en el estilo de vida y metformina; y 2) Planificar la rotación gradual del antipsicótico hacia un agente con perfil metabólico neutro, siendo Aripiprazol o Ziprasidona las opciones de elección. Suspender el antipsicótico sin sustituto (D) gatillaría una recaída psicótica grave. Perla de examen: Olanzapina tiene el mayor riesgo de ganancia ponderal y diabetes mellitus entre los atípicos; Aripiprazol es neutro metabólicamente.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

En un paciente que ha presentado un primer episodio psicótico esquizofrénico y alcanza la remisión sintomática, las guías internacionales y la guía GES N° 34 recomiendan mantener el tratamiento antipsicótico de forma continua y a dosis terapéutica durante un período mínimo de 1 a 2 años. La suspensión precoz del antipsicótico antes del año se asocia a una tasa de recaída psicótica superior al 70-80% en los siguientes 12 meses, con el agravante de que cada recaída produce deterioro neurocognitivo residual y mayor riesgo de refractariedad. En pacientes con dos o más episodios psicóticos previos, la mantención se prolonga a 5 años o de por vida. Perla de examen: En un primer episodio de esquizofrenia con remisión completa, la duración mínima del tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos es de 1 a 2 años.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: D**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

La risa sin motivo orienta a Hebefrenia. El cuadro clínico es sugerente de EQZ.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: B**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

Tiene un TDC clásico, con un delirio sistematizado y afectación únicamente en esa área. Si bien es relativamente joven, no tiene alucinaciones ni síntomas negativos o primarios de esquizofrenia.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: B**

5.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES**

Es una EQZ clásica.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma**

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de Esquizofrenia Refractaria (falla terapéutica demostrada a dos antipsicóticos distintos en dosis plenas durante al menos 6 semanas cada uno, incluyendo un antipsicótico atípico como la risperidona). En este escenario clínico, el único fármaco que ha demostrado eficacia estadísticamente significativa y superior es la Clozapina. Dado que su hemograma basal es normal (leucocitos > 3.500 y RAN > 2.000), la indicación correcta es iniciar Clozapina bajo el protocolo estricto de farmacovigilancia hematológica obligatoria (hemograma semanal los primeros 6 meses). Los demás distractores corresponden a errores diagnósticos graves. Perla de examen: En esquizofrenia refractaria tras falla de 2 antipsicóticos plenos, la Clozapina es el tratamiento de elección.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma**

El paciente presenta una agranulocitosis inducida por Clozapina (RAN < 1.000/mm³, en este caso 790/mm³). Esta es una complicación potencialmente mortal por sepsis neutropénica fulminante. La conducta médica normada e innegociable es: 1) Suspensión inmediata y definitiva de la Clozapina; 2) Hospitalización en aislamiento protector; 3) Evaluación hematológica para eventual uso de Filgrastim (G-CSF); y 4) Registrar la contraindicación absoluta y permanente de reexposición a Clozapina de por vida. Reducir la dosis (A) o esperar (E) expone al paciente a muerte inminente por shock séptico. El biperideno (D) no tiene ninguna acción sobre la médula ósea. Perla de examen: Con Clozapina, un RAN < 1.000/mm³ exige la suspensión inmediata y definitiva del fármaco sin posibilidad de reexposición de por vida.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

El cuadro se inicia tras un evento traumático de amenaza vital hace 3 semanas y los síntomas llevan 10 días de evolución. Dado que la duración del cuadro es menor a 1 mes (menos de 30 días desde el evento), la clasificación nosológica precisa según el DSM-5 es Trastorno de Estrés Agudo. Si los síntomas de intrusión, evitación e hiperalerta persistieran más allá del mes de evolución, el diagnóstico se reclasificaría como Trastorno de Estrés Postraumático (A). No existen elementos psicóticos (C) ni crisis paroxísticas espontáneas desvinculadas del trauma (D). Perla de examen: En patología postraumática, la frontera temporal es exactamente 1 mes: menos de 30 días es Estrés Agudo, más de 30 días es TEPT.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

1.13.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

La Prazosina es un antagonista selectivo de los receptores alfa-1 adrenérgicos que cruza la barrera hematoencefálica y disminuye la hiperactividad noradrenérgica central durante el sueño REM. Cuenta con sólida evidencia clínica para la reducción específica de las pesadillas traumáticas y la mejoría de la calidad del sueño en pacientes con TEPT. Las benzodiacepinas como Diazepam (B) están contraindicadas porque alteran la arquitectura del sueño REM y aumentan la desensibilización negativa. El haloperidol (C) y el metilfenidato (E) no tienen indicación en este escenario. Perla de examen: Prazosina es el fármaco de elección para el tratamiento de las pesadillas traumáticas e insomnio del TEPT.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

5.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

Trastorno por estrés agudo

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

De libro y lleva más de 4 semanas.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

Es un TEPT clásico.

**PREGUNTA 52** **Respuesta: A**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

**PREGUNTA 53** **Respuesta: E**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

**PREGUNTA 54** **Respuesta: C**

5.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo**

Caso clínico oficial EUNACOM para Trastorno por estrés postraumático.

## BLOQUE 4 TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A** **Enuresis**

5.01.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enuresis" (5.01.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve**

La paciente presenta una idea delirante estructurada (persecutoria con tinte somático) que persiste por más de 1 mes (4 meses de evolución) en ausencia de los síntomas cardinales de esquizofrenia (no hay alucinaciones auditivas, disgregación del lenguaje ni síntomas negativos como abulia o aplanamiento) y con conservación intacta del funcionamiento profesional y social fuera de la temática del delirio. Corresponde clásicamente a un Trastorno Delirante Crónico. La esquizofrenia (A) cursa con disfunción sociolaboral global y síntomas negativos. El trastorno psicótico breve (C) dura menos de 30 días. Perla de examen: La conservación de la funcionalidad laboral e interpersonal fuera de la temática delirante es el sello característico del Trastorno Delirante Crónico.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: B**

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve**

El cuadro se inició bruscamente tras un estresor biográfico masivo (pérdida del sustento laboral en un incendio), cursó con síntomas psicóticos floridos (alucinaciones, delirio, desorganización) y se resolvió completamente con restitución ad integrum a los 18 días de evolución (dentro del rango temporal menor a 1 mes). El diagnóstico DSM-5 definitivo es Trastorno Psicótico Breve con desencadenante grave (anteriormente llamado psicosis reactiva breve). El trastorno esquizofreniforme (C) requiere una duración de entre 1 y 6 meses. La esquizofrenia (A) requiere al menos 6 meses de signos continuos. Perla de examen: El trastorno psicótico breve dura menos de 30 días y se resuelve con restitución completa al estado premórbido.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo**

El paciente presenta la presentación clásica del Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): hipertermia severa, rigidez muscular plástica en caño de plomo, inestabilidad autonómica, compromiso de conciencia y elevación masiva de la CPK con leucocitosis en contexto de uso de antipsicóticos típicos. La primera medida obligatoria y vital es la suspensión inmediata del fármaco bloqueador dopaminérgico (Haloperidol) y el traslado a UPC para soporte hemodinámico e hidratación endovenosa agresiva para prevenir la falla renal por rabdomiólisis. Mantener el antipsicótico o aumentarlo (A y E) es una conducta mortal. El biperideno (C) no es efectivo para el SNM. Perla de examen: En el SNM, suspender de inmediato el antipsicótico es la primera medida innegociable.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo**

El cuadro corresponde a un Síndrome Serotoninérgico desencadenado por la interacción farmacológica entre un ISRS (Paroxetina) y un analgésico opioide con potente inhibición de la recaptación de serotonina (Tramadol). Los criterios diagnósticos de Hunter establecen que la presencia de clonus (inducible, espontáneo u ocular) asociado a agitación, diaforesis, diarrea e hiperreflexia patológica es diagnóstica de toxicidad serotoninérgica. Esta hiperreflexia y clonus contrastan nítidamente con el Síndrome Neuroléptico Maligno, en el cual predomina la rigidez muscular continua en caño de plomo con reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos y sin diarrea. Perla de examen: La hiperreflexia osteotendinosa y el clonus diferencian al Síndrome Serotoninérgico de la rigidez en caño de plomo del Síndrome Neuroléptico Maligno.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: B**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo**

En el Síndrome Neuroléptico Maligno, la contracción muscular sostenida y tónica produce rabdomiólisis masiva con liberación de grandes cantidades de mioglobina y enzimas musculares a la sangre (CPK > 20.000 UI/L). La mioglobina precipita en los túbulos renales formando cilindros que causan obstrucción intratubular y toxicidad tubular oxidativa directa, lo que desencadena una necrosis tubular aguda oligúrica grave que históricamente constituía la causa primaria de muerte. La fluidoterapia agresiva con suero salino isotónico (3 a 6 L/día) busca expandir el volumen intravascular y mantener un flujo urinario elevado (meta 2 a 3 mL/kg/h) para arrastrar la mioglobina antes de que precipite, salvaguardando la función renal. Perla de examen: La meta de la fluidoterapia en el SNM con rabdomiólisis es forzar diuresis para evitar la falla renal por mioglobina.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

1.13.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo**

En los casos graves, refractarios o con hipertermia extrema de Síndrome Neuroléptico Maligno, los dos fármacos con indicación formal de rescate son: 1) Dantroleno sódico endovenoso (relajante muscular de acción periférica que bloquea los canales de rianodina inhibiendo la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y deteniendo el hipermetabolismo muscular); y 2) Bromocriptina (agonista de los receptores dopaminérgicos D2 que restaura el tono dopaminérgico central en el hipotálamo y los ganglios basales). El flumazenil (B) es para sobredosis de benzodiacepinas. La naloxona (C) es para intoxicación por opioides. El haloperidol (D) está estrictamente proscrito por ser la causa del cuadro. La ciproheptadina (E) es para síndrome serotoninérgico. Perla de examen: Dantroleno EV y Bromocriptina son los fármacos de rescate específicos en el SNM refractario.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada**

La combinación de Haloperidol 5 mg IM con Lorazepam 2 a 4 mg IM es el estándar de oro en los servicios de urgencia para el manejo de la agitación psicomotora severa no orgánica. La sinergia entre el antipsicótico (bloqueo D2 rápido) y la benzodiacepina (agonismo gabaérgico ansiolítico y sedante) permite una sedación conductual más veloz y eficaz con menores dosis de cada agente, con la enorme ventaja adicional de que el Lorazepam previene la aparición de distonías agudas inducidas por el haloperidol. La alternativa B comete un error mortal: asociar Olanzapina IM con Lorazepam IM está formalmente contraindicado por riesgo de depresión cardiorrespiratoria e hipotensión severa fatal. Los demás fármacos no tienen indicación en este contexto. Perla de examen: Haloperidol 5 mg IM + Lorazepam 2 mg IM es la combinación de elección en urgencias para la agitación psicomotora.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada**

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta un Delirium hiperactivo (síndrome confusional agudo caracterizado por inicio brusco, fluctuación circadiana vespertina, desorientación y alucinaciones visuales en un adulto mayor hospitalizado). El primer pilar terapéutico es identificar y tratar la causa subyacente (dolor, retención urinaria, infección urinaria, fármacos anticolinérgicos, deshidratación). Si la agitación pone en riesgo la seguridad física del paciente, el fármaco de elección es Haloperidol en dosis muy bajas (0.5 a 1 mg vía oral o intramuscular), el cual controla la psicosis confusional sin causar depresión respiratoria. Las benzodiacepinas (A) están formalmente contraindicadas en el delirium no alcohólico porque producen sedación paradójica, empeoran la confusión cognitiva y aumentan el riesgo de caídas y broncoaspiración. Perla de examen: En el delirium del adulto mayor, las benzodiacepinas están contraindicadas; el fármaco de elección es Haloperidol a dosis muy bajas (0.5-1 mg).

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: B**

**Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada**

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Múltiples alertas de seguridad farmacológica de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), reflejadas en las guías del MINSAL, prohíben estrictamente la administración parenteral simultánea de Olanzapina IM junto con Benzodiacepinas parenterales (como Lorazepam IM o Diazepam EV/IM). La coadministración parenteral de ambos fármacos deprime de forma sinérgica y fulminante los centros bulbares cardiorrespiratorios, produciendo bradicardia extrema, hipotensión severa, paro respiratorio y muerte súbita. Si se administra Olanzapina IM, deben transcurrir al menos 2 horas antes de considerar el uso de una benzodiacepina. En cambio, Haloperidol + Lorazepam IM (A) es una combinación segura y ampliamente avalada. Trampa mortal de examen: Nunca coadministrar Olanzapina IM con benzodiacepinas parenterales por riesgo de paro cardiorrespiratorio fatal.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada**

1.09.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La contención mecánica es una medida terapéutica de última instancia regulada estrictamente por la Ley N° 21.331 (del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental). Sus exigencias legales y clínicas innegociables son: 1) Indicación médica formal, fundada y escrita en la ficha clínica con hora de inicio; 2) Supervisión médica y de enfermería continua con registro cada 15 a 30 minutos de signos vitales, nivel de conciencia y perfusión de extremidades; 3) Retiro precoz y progresivo apenas ceda la agitación; 4) El paciente DEBE colocarse en decúbito supino con cabecera elevada a 30-45° (nunca prono por riesgo de asfixia posicional [C]); y 5) Las sujeciones deben fijarse a la estructura fija de la cama, nunca a barandas móviles (E). Perla de examen: La contención física requiere orden médica escrita obligatoria y monitorización de pulsos y signos vitales cada 15 a 30 minutos.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: E**

**Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada**

5.01.2.002 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 30). Evalúa el manejo clínico de Agitación psicomotora según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: B**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta la tríada clásica de la Encefalopatía de Wernicke (oftalmoplejía/nistagmo, ataxia y confusión/sopor) agravada por hipoglicemia severa. La regla de oro absoluta e innegociable en urgencias es que en todo paciente con alcoholismo crónico o desnutrición severa, la administración de TIAMINA (Vitamina B1, 100 a 300 mg EV o IM) DEBE preceder o administrarse de forma estrictamente simultánea al suero glucosado. Administrar glucosa sola (A) consume la escasa tiamina de reserva como cofactor metabólico, precipitando la necrosis hemorrágica irreversible de los cuerpos mamilares y el tronco encefálico (Síndrome de Korsakoff o muerte). La fenitoína (C) no previene ni trata el Wernicke. Perla de examen: La Tiamina se administra SIEMPRE antes de la glucosa en el paciente alcohólico para evitar desencadenar una encefalopatía de Wernicke irreversible.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En pacientes con insuficiencia hepatocelular o cirrosis hepática demostrada, las benzodiacepinas de vida media larga que dependen de la oxidación microsómica por citocromo P450 hepático (como Diazepam y Clordiazepóxido) sufren una dramática disminución en su depuración, acumulándose de forma impredecible y gatillando una encefalopatía hepática grave o coma. Por ello, la benzodiacepina de elección absoluta en pacientes cirróticos con abstinencia alcohólica es el LORAZEPAM (o alternativamente Oxazepam), ya que se metaboliza exclusivamente por glucuronidación directa, proceso que no depende del citocromo P450 y que se encuentra conservado en la cirrosis, además de carecer de metabolitos activos. Perla de examen: En abstinencia alcohólica con cirrosis hepática, el fármaco de elección es Lorazepam porque no depende del citocromo P450.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro corresponde típicamente a una Alucinosis Alcohólica: complicación de la abstinencia alcohólica que aparece en las primeras 12 a 24 horas del cese de consumo, caracterizada por la presencia de alucinaciones auditivas o visuales vívidas en un paciente con SENSORIO RIGUROSAMENTE LÚCIDO Y PLENA ORIENTACIÓN témporo-espacial. Esta lucidez de la conciencia es la diferencia cardinal con el Delirium Tremens (A), el cual ocurre más tardíamente (48-72 h) y se define obligatoriamente por confusión global, desorientación, estupor y grave inestabilidad autonómica. La esquizofrenia (C) exige al menos 6 meses de evolución. Perla de examen: La alucinosis alcohólica cursa con sensorio lúcido y orientado; el delirium tremens cursa con desorientación y compromiso global de conciencia.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: C**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

5.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene alcoholismo y está motivado para dejar de consumir, pero Gene antecedente de un síndrome de absGnencia grave, con delirium tremens previo, por lo que lo razonable es que inicie la disconGnuación bajo supervisión médica, en el hospital. Si presentara síntomas de absGnencia grave, se trataría con Lorazepam, ya que el diazepam no se recomienda en el daño hepático crónico.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

5.01.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 148). Evalúa el manejo clínico de Delirium según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke**

5.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retardo mental" (5.01.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** Encopresis

5.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Encopresis" (5.01.1.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 74** **Respuesta: D**

**Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Presenta un consumo perjudicial de alcohol con escasa conciencia de enfermedad (etapa precontemplativa), por lo que primero se debe trabajar la motivación al cambio. De nada sirve iniciar fármacos o derivar a psicoterapia, si no Gene intenciones de cambiar.

---

**PREGUNTA 75** **Respuesta: C**

**Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

En la intoxicación por cocaína con complicaciones cardiovasculares (dolor torácico, isquemia miocárdica, hipertensión severa), los betabloqueadores puros no selectivos (como Propranolol) o selectivos (Atenolol, Metoprolol) están formalmente contraindicados. Al antagonizar los receptores beta-2 vasculares que median vasodilatación, la gran sobrecarga de noradrenalina y adrenalina circulante estimula libremente los receptores alfa-1 vasculares (fenómeno de estimulación alfa sin oposición), lo que intensifica drásticamente el vasoespasmo de las arterias coronarias y la vasoconstricción periférica, pudiendo desencadenar infarto masivo transmural, crisis hipertensiva maligna y muerte. El tratamiento de primera línea son las benzodiacepinas EV (A y E), nitratos (B) y AAS (D). Perla de examen: Los betabloqueadores puros están contraindicados en dolor torácico por cocaína por el riesgo de vasoespasmo alfa sin oposición.

---

**PREGUNTA 76** **Respuesta: B**

**Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)**

5.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El Flumazenil es un antagonista competitivo selectivo de los receptores GABA-A. Si bien revierte rápidamente el efecto de las benzodiacepinas en intoxicaciones agudas accidentales en pacientes sin consumo previo (ej. reversión de sedación post-endoscopía), está formalmente contraindicado o fuertemente desaconsejado en pacientes con consumo crónico de benzodiacepinas (como esta paciente con 10 años de uso de clonazepam). En estos pacientes, el bloqueo súbito del receptor GABA precipita de forma violenta un síndrome de abstinencia agudo caracterizado por convulsiones generalizadas y status epiléptico de muy difícil manejo que puede ser letal. Dado que la paciente mantiene signos vitales estables y adecuada ventilación, la conducta correcta es la observación protegida y el soporte clínico hasta que el fármaco se metabolice. Perla de examen: El flumazenil no debe usarse en sobredosis de benzodiacepinas en pacientes dependientes crónicos por riesgo de status epiléptico.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: C**

**Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)**

5.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un síndrome adrenérgico: midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las clásicas causas.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta un Trastorno de la Personalidad Esquizoide (Clúster A): patrón dominante de distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. El hallazgo distintivo es que el paciente genuinamente NO desea ni disfruta de las relaciones íntimas, muestra preferencia por actividades solitarias y manifiesta indiferencia ante la aprobación o crítica ajena, sin angustia egodistónica. En contraste, el trastorno de personalidad por evitación (A) y la fobia social (E) se caracterizan porque los pacientes sí anhelan el contacto humano, pero se aíslan por miedo angustioso al rechazo o la humillación. El esquizotípico (C) presenta pensamiento mágico y rarezas perceptivas. Perla de examen: El paciente esquizoide no tiene ningún interés en socializar; el evitativo desea amigos pero teme el rechazo.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: B**

1.09.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

El cuadro corresponde clínicamente a un Trastorno de Personalidad Límite (Borderline), caracterizado por desregulación afectiva severa, impulsividad, automutilaciones (cortes en piel) y miedo intenso al abandono. La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT), desarrollada específicamente por Marsha Linehan para pacientes con desregulación emocional y conductas autolesivas repetitivas, es el modelo psicoterapéutico de primera línea que cuenta con la mayor evidencia científica en ensayos clínicos aleatorizados, demostrando reducir de forma significativa los gestos parasuicidas, las consultas en urgencias y las hospitalizaciones. Los psicofármacos se usan únicamente como apoyo sintomático. La TEC (A) no está indicada para trastornos de la personalidad. Perla de examen: La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) es la intervención de elección para el Trastorno Límite de Personalidad.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Es un TP limítrofe clásico.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: C**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Es un clásico trastorno limítrofe de la personalidad.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

5.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C**

Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria**

El paciente cumple los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) subtipo combinado: presencia de síntomas de inatención, hiperactividad motora e impulsividad presentes de forma continua durante más de 6 meses, que debutaron antes de los 12 años (presentes desde los 5 años) y que se manifiestan de forma consistente en al menos dos entornos diferentes (colegio y hogar), produciendo disfunción escolar. El tratamiento farmacológico de primera elección avalado por guías clínicas mundiales y MINSAL son los psicoestimulantes, específicamente el Metilfenidato, complementado con adaptaciones psicopedagógicas curriculares (programa PIE) y orientación a los padres. Perla de examen: En TDAH escolar con compromiso en dos o más entornos, el Metilfenidato es el tratamiento farmacológico de primera línea.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: B**

4.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria**

La paciente presenta una Anorexia Nervosa severa con criterios de hospitalización médica inmediata de urgencia: desnutrición crítica (IMC 13.5 < 14 kg/m²), bradicardia extrema (< 40 lpm: 34 lpm), hipotensión severa (75/45 mmHg) e hipotermia. Estas alteraciones confieren un riesgo inminente de arritmias ventriculares letales, asistolia y colapso circulatorio. La única conducta admisible es la hospitalización inmediata en cama monitorizada (pediatría/UPC), con estabilización hemodinámica y protocolo de realimentación enteral lenta y progresiva con control estricto de fósforo para prevenir el síndrome de realimentación. La fluoxetina ambulatoria (C) o el manejo en casa (A y D) constituyen una negligencia médica con desenlace potencialmente fatal. Perla de examen: En anorexia nervosa, un IMC < 14 kg/m² o bradicardia < 40 lpm obligan a la hospitalización médica inmediata en cama monitorizada.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: C**

5.01.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria**

Es una anorexia nerviosa clásica (anorexia nervosa en latín) con restricción alimentaria, bajo peso (IMC 16 kg/m²), minimización del problema, normalización de la delgadez y escasa conciencia de problema. Las niñas y adolescentes son el grupo en el que suele comenzar.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

5.01.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Trastorno conducta oposicionista desafiante" (5.01.1.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: C**

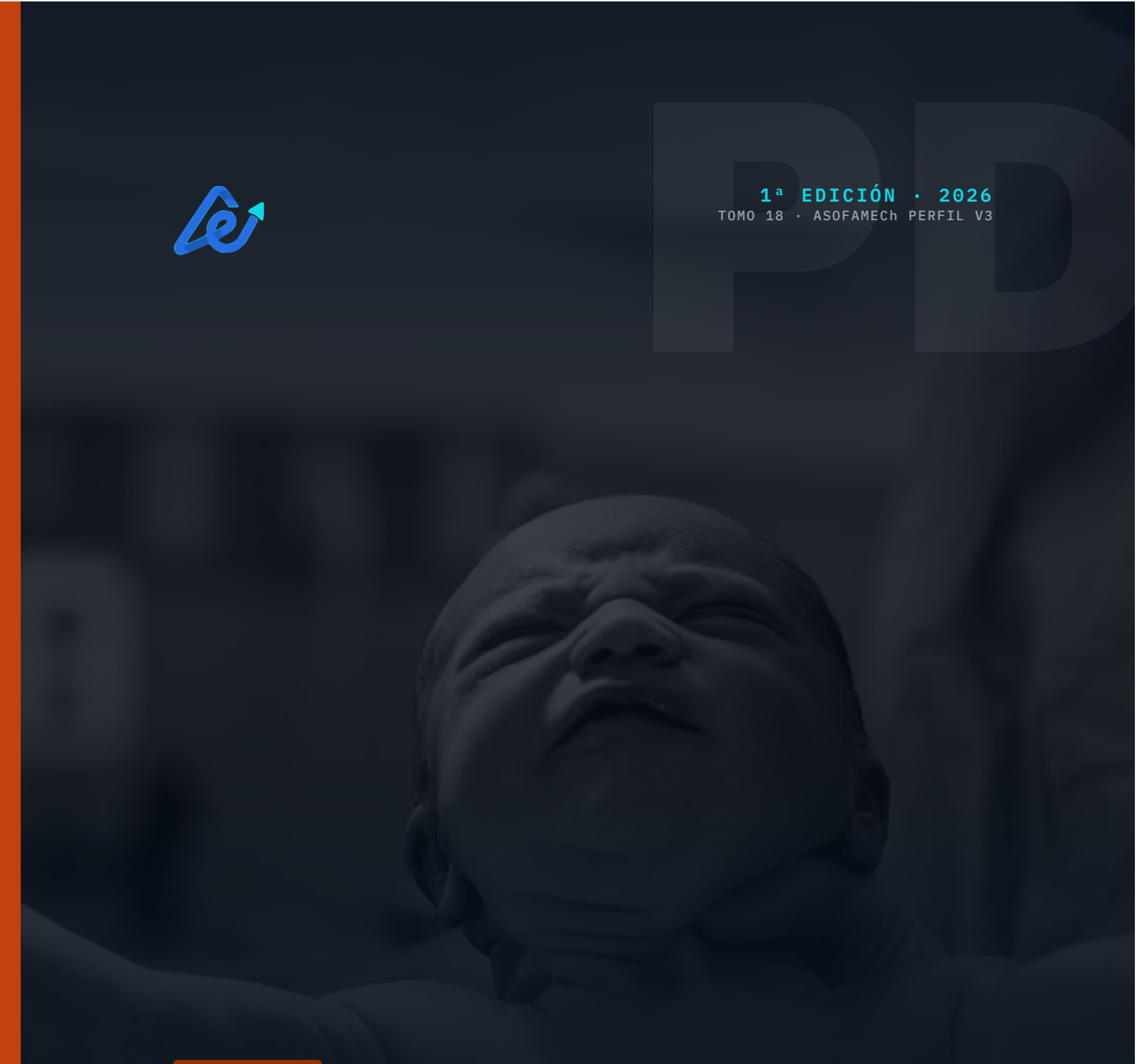
5.01.1.031 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria**

Trastorno de conducta: patrón repetitivo y persistente de comportamiento que viola los derechos básicos de otros o normas sociales (agresión, robo, absentismo, consumo de sustancias). Inicio antes de los 15 años. Requiere intervención multidisciplinaria.

---

1ª EDICIÓN · 2026
TOMO 18 · ASOFAMECh PERFIL V3



MÓDULO 3

# PEDIATRÍA GENERAL

## 90 Preguntas de Práctica

Neonatología

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Pediatría General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 18 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI** | | | | | |
| 2.01.1.020 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.032 | Leucemias | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.035 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q13 | Tomo 18 · C.13 (Pág. 30) |
| 2.01.1.037 | Tumores sólidos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.048 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.050 | Cardiopatías congénitas frecuentes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.072 | Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 18 · C.7 (Pág. 18) |
| 2.01.1.083 | Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7) |
| 2.01.1.095 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.141 | Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.001 | Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9) |
| 2.01.2.005 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 18 · C.6 (Pág. 16) |
| 2.01.2.010 | Hemorragia digestiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 18 · C.1 (Pág. 6) |
| 2.01.2.013 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 18 · C.4 (Pág. 12) |
| 2.01.2.016 | Meningococcemia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 18 · C.21 (Pág. 46) |
| 2.01.2.023 | Shock | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 18 · C.29 (Pág. 62) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.024 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 18 · C.30 (Pág. 64) |
| 2.01.2.144 | SARS Cov 2 COVID 19 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q7 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS** | | | | | |
| 2.01.1.009 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q32 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.011 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |
| 2.01.1.015 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27 | Tomo 18 · 18.7 (Pág. 24) |
| 2.01.1.024 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.027 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.038 | Constipación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.062 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.076 | Talla baja | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 18 · C.11 (Pág. 26) |
| 2.01.1.111 | Malformaciones vasculares cutáneas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.002 | Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q26 | Tomo 18 · 18.6 (Pág. 20) |
| 2.01.2.003 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29 | Tomo 18 · 18.8 (Pág. 28) |
| 2.01.2.004 | Compromiso de conciencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q22 | Tomo 18 · C.5 (Pág. 14) |
| 2.01.2.011 | Hipertensión endocraneana | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23 | Tomo 18 · C.2 (Pág. 8) |
| 2.01.2.017 | Muerte súbita-ALTE, BRUE | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 18 · C.13 (Pág. 30) |
| 2.01.2.018 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q30 | Tomo 18 · C.14 (Pág. 32) |
| 2.01.2.019 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 18 · C.25 (Pág. 54) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.025 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q36 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.026 | Traumatismo encéfalo- craneano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q25 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO** | | | | | |
| 2.01.1.007 | Enteroparasitosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.008 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q47 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.023 | Faringoamigdalitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q38 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.025 | Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.029 | Sinusitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q39 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.039 | Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q49 | Tomo 18 · 18.11 (Pág. 41) |
| 2.01.1.046 | Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51 | Tomo 18 · 18.12 (Pág. 45) |
| 2.01.1.054 | Soplos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.058 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.067 | Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 18 · C.4 (Pág. 12) |
| 2.01.1.073 | Diabetes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.1.074 | Hiperplasia suprarrenal congénita | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |
| 2.01.1.081 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q53 | Tomo 18 · C.16 (Pág. 36) |
| 2.01.1.108 | Dermatitis del pañal y de contacto | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q43 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.006 | Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q52 | Tomo 18 · 18.14 (Pág. 49) |
| 2.01.2.007 | Emergencia hipertensiva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.012 | Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 18 · C.3 (Pág. 10) |
| 2.01.2.020 | Paro cardiorrespiratorio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 18 · C.18 (Pág. 40) |
| **BLOQUE 4: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS** | | | | | |
| 2.01.1.010 | Hepatitis viral | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.013 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.018 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67 | Tomo 18 · 18.10 (Pág. 37) |
| 2.01.1.026 | Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.030 | Adenopatías | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.043 | Hemorragia digestiva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.055 | Alergias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q58 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.056 | Inmunodeficiencias | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q59 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.1.057 | Mesenquimopatías | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.093 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.116 | Enterocolitis necrotizante (ECN) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.121 | Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 18 · 18.17 (Pág. 60) |
| 2.01.1.127 | TORCH | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q62 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.128 | Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 18 · 18.16 (Pág. 58) |
| 2.01.1.133 | Malformaciones congénitas más frecuentes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.008 | Epistaxis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 18 · C.10 (Pág. 24) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.014 | Intoxicaciones | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 18 · C.19 (Pág. 42) |
| 2.01.2.021 | Politraumatismos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q66 | Tomo 18 · C.27 (Pág. 58) |
| **BLOQUE 5: NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS** | | | | | |
| 2.01.1.001 | Desnutrición | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.006 | Coqueluche | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.016 | Mononucleosis infecciosa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.031 | Anemia ferropriva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.036 | Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.042 | Fibrosis quística | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.069 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.075 | Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 18 · C.10 (Pág. 24) |
| 2.01.1.088 | Criptorquidia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.096 | Estrabismo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q79 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.105 | Alteraciones pigmentarias | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.107 | Dermatitis atópica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q81 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.109 | Ectoparasitosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q82 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.131 | Sinequias vulvares | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q83 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.009 | Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 18 · 18.20 (Pág. 72) |
| 2.01.2.015 | Meningitis bacteriana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q84 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.2.022 | Quemaduras | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q85 | Tomo 18 · C.28 (Pág. 60) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.027 | **Estatus convulsivo en el niño** | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q86 | Tomo 18 · C.43 (Pág. 90) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Pediatría General · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.1.001 | Desnutrición | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q73 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.006 | Coqueluche | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q74 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.007 | Enteroparasitosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.008 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q47 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.009 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q32 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.010 | Hepatitis viral | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q55 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.011 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q33 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |
| 2.01.1.013 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q71 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.015 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q27 | Tomo 18 · 18.7 (Pág. 24) |
| 2.01.1.016 | Mononucleosis infecciosa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q75 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.018 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67 | Tomo 18 · 18.10 (Pág. 37) |
| 2.01.1.020 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q12 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.023 | Faringoamigdalitis | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q38 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.024 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.025 | Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q54 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.026 | Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.1.027 | Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q28 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.029 | Sinusitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q39 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.030 | Adenopatías | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q56 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.031 | Anemia ferropriva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q76 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.032 | Leucemias | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.035 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q13 | Tomo 18 · C.13 (Pág. 30) |
| 2.01.1.036 | Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.037 | Tumores sólidos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.038 | Constipación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q19 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.039 | Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q49 | Tomo 18 · 18.11 (Pág. 41) |
| 2.01.1.042 | Fibrosis quística | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q77 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.043 | Hemorragia digestiva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q57 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.046 | Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51 | Tomo 18 · 18.12 (Pág. 45) |
| 2.01.1.048 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.050 | Cardiopatías congénitas frecuentes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.054 | Soplos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.055 | Alergias | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q58 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.056 | Inmunodeficiencias | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q59 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.1.057 | Mesenquimopatías | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q60 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.1.058 | Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q48 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.062 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.067 | Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 18 · C.4 (Pág. 12) |
| 2.01.1.069 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q90 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.072 | Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 18 · C.7 (Pág. 18) |
| 2.01.1.073 | Diabetes | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.1.074 | Hiperplasia suprarrenal congénita | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q42 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |
| 2.01.1.075 | Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q89 | Tomo 18 · C.10 (Pág. 24) |
| 2.01.1.076 | Talla baja | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 18 · C.11 (Pág. 26) |
| 2.01.1.081 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q53 | Tomo 18 · C.16 (Pág. 36) |
| 2.01.1.083 | Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7) |
| 2.01.1.088 | Criptorquidia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q78 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.093 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q72 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.095 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.096 | Estrabismo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q79 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.105 | Alteraciones pigmentarias | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q80 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.107 | Dermatitis atópica | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q81 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.108 | Dermatitis del pañal y de contacto | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q43 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.109 | Ectoparasitosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q82 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.1.111 | Malformaciones vasculares cutáneas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q21 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.116 | Enterocolitis necrotizante (ECN) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.121 | Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q70 | Tomo 18 · 18.17 (Pág. 60) |
| 2.01.1.127 | TORCH | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q62 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.128 | Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q69 | Tomo 18 · 18.16 (Pág. 58) |
| 2.01.1.131 | Sinequias vulvares | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q83 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.133 | Malformaciones congénitas más frecuentes | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q63 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.1.141 | Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q9 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.001 | Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 18 · 18.3 (Pág. 9) |
| 2.01.2.002 | Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q26 | Tomo 18 · 18.6 (Pág. 20) |
| 2.01.2.003 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29 | Tomo 18 · 18.8 (Pág. 28) |
| 2.01.2.004 | Compromiso de conciencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q22 | Tomo 18 · C.5 (Pág. 14) |
| 2.01.2.005 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q16 | Tomo 18 · C.6 (Pág. 16) |
| 2.01.2.006 | Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q52 | Tomo 18 · 18.14 (Pág. 49) |
| 2.01.2.007 | Emergencia hipertensiva | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 18 · C.9 (Pág. 22) |
| 2.01.2.008 | Epistaxis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q64 | Tomo 18 · C.10 (Pág. 24) |
| 2.01.2.009 | Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 18 · 18.20 (Pág. 72) |
| 2.01.2.010 | Hemorragia digestiva | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q4 | Tomo 18 · C.1 (Pág. 6) |
| 2.01.2.011 | Hipertensión endocraneana | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q23 | Tomo 18 · C.2 (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.2.012 | Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 18 · C.3 (Pág. 10) |
| 2.01.2.013 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 18 · C.4 (Pág. 12) |
| 2.01.2.014 | Intoxicaciones | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q65 | Tomo 18 · C.19 (Pág. 42) |
| 2.01.2.015 | Meningitis bacteriana | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q84 | Tomo 18 · C.8 (Pág. 20) |
| 2.01.2.016 | Meningococcemia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q5 | Tomo 18 · C.21 (Pág. 46) |
| 2.01.2.017 | Muerte súbita-ALTE, BRUE | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 18 · C.13 (Pág. 30) |
| 2.01.2.018 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q30 | Tomo 18 · C.14 (Pág. 32) |
| 2.01.2.019 | Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 18 · C.25 (Pág. 54) |
| 2.01.2.020 | Paro cardiorrespiratorio | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q46 | Tomo 18 · C.18 (Pág. 40) |
| 2.01.2.021 | Politraumatismos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q66 | Tomo 18 · C.27 (Pág. 58) |
| 2.01.2.022 | Quemaduras | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | — | Q85 | Tomo 18 · C.28 (Pág. 60) |
| 2.01.2.023 | Shock | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q6 | Tomo 18 · C.29 (Pág. 62) |
| 2.01.2.024 | Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 18 · C.30 (Pág. 64) |
| 2.01.2.025 | Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q36 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.026 | Traumatismo encéfalo- craneano | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q25 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |
| 2.01.2.027 | Estatus convulsivo en el niño | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q86 | Tomo 18 · C.43 (Pág. 90) |
| 2.01.2.144 | SARS Cov 2 COVID 19 | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | — | Q7 | Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI

PREGUNTA 1 2.01.1.032

**1.** **Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm3, plaquetas: 45.000 por mm3, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Déficit de vitamina B12
B) Anemia hemolítica
C) Enfermedad celíaca
D) Leucemia aguda
E) Fibrosis quística

PREGUNTA 2 2.01.1.037

**2.** **Un niño de 7 años presenta orinas oscuras, desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Se solicitan exámenes entre los que destacan bilirrubina: 1,0 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sedimento de orina con 30-40 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hapatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Linfoma

PREGUNTA 3 2.01.1.050

**3.** **Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:**

A) Trasposición de grandes vasos
B) Comunicación interauricular
C) Coartación aórtica
D) Canal auriculoventricular
E) Comunicación interventricular

PREGUNTA 4 2.01.2.010

**4.** **Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimenta- rios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómi- tos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esofagitis péptica
B) Esofagitis erosiva
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Gastritis por Helicobacter pylori

PREGUNTA 5 2.01.2.016

**5.** **[URGENCIA: Meningococcemia · 2.01.2.016] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Meningococcemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 6 2.01.2.023

**6.** **Una lactante de 2 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, de 24 horas de evolución. Es llevada al servicio de urgencias debido a que ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen físico se observa soporosa, con un llenado capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158 latidos por minuto. La temperatura es de 39,3°C. Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?**

A) Administrar solución fisiológica por vía endovenosa
B) Administrar bicarbonato por vía endovenosa
C) Administrar adrenalina por vía endovenosa
D) Administrar hidrocortisona por vía endovenosa
E) Administrar glucosa por vía endovenosa

PREGUNTA 7 2.01.2.144

**7. Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39ºC, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está con compromiso hemodinámico, con frecuencia cardíaca de 120x' y PA: 90/50 mmHg, por lo que que es manejado con suero fisiológico endovenoso, con respuesta parcial. Tiene antecedente de PCR positiva para Covid-19 hace 30 días y se solicitan nuevos exámenes, que muestran hematocrito: 33%, blancos: 14.000 por mm3, plaquetas: 80.000 por mm3, VHS: 76 mmHg, PCR: 15,5 mg/L, dímero D: 670 ng/ml y troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Sepsis bacteriana
B) Síndrome inflamatorio multisistémico
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Reinfección por Covid-19
E) Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTA 8 2.01.1.072

**8. Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:**

A) Pubertad precoz central
B) Pubertad precoz periférica
C) Pubertad temprana
D) Hiperplasia suprarrenal
E) Adrenarquia temprana

PREGUNTA 9 2.01.1.141

**9. Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por déficit atencional
B) Trastorno generalizado del desarrollo
C) Parálisis cerebral
D) Distrofia muscular
E) Trastorno del lenguaje

PREGUNTA 10 2.01.1.083

**10. Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas de edad gestacional, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico, tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y presencia de signo de Babinski. El diagnóstico más probable es:**

A) Estereotipia de la marcha
B) Retraso del desarrollo psicomotor
C) Diplejia espástica
D) Polineuropatía
E) Distrofia muscular

PREGUNTA 11 2.01.2.001

**11. Un lactante de 12 meses acude al vacunatorio del CESFAM con su calendario al día hasta los 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que le corresponde recibir según el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de Chile?**

A) Hexavalente, Hepatitis A y Varicela
B) Tresvírica, Meningocócica ACWY y Neumocócica conjugada
C) Tresvírica, Varicela y Hexavalente
D) Neumocócica conjugada, Hepatitis A y Polio oral
E) Meningocócica ACWY, Varicela y Hepatitis B monovalente

PREGUNTA 12 2.01.1.020

**12. Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal y subcostal. Al examen físico tiene FR: 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Virus respiratorio sincicial
B) Bordetella pertusis
C) Virus influenza
D) Virus parainfluenza
E) Neumococo

PREGUNTA 13 2.01.1.035

**13. Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm3 y glóbulos blancos: 5.600 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Leucemia aguda
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Púrpura trombocitpénico trombótico
D) Hemofilia
E) Enfermedad de Von Willebrand

PREGUNTA 14 2.01.1.048

**14. Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Anticuerpos IgA antiendomisio
B) Cuantificación de inmunoglobulinas
C) Test del sudor
D) Colonoscopía
E) 17 – OH – progesterona

PREGUNTA 15 2.01.1.095

**15. Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

PREGUNTA 16 2.01.2.005

**16. Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, $SatO_2$ 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno
B) Adrenalina subcutánea
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Antibióticos EV
E) Solo oxígeno y observar

PREGUNTA 17 2.01.2.013

**17. Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. $SatO_2$ 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min. FR 50/min, uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?**

A) Ventilación no invasiva (VNI/CPAP) o cambio a mascarilla de alto flujo
B) Intubación orotraqueal inmediata
C) Aumentar flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min
D) Adrenalina nebulizada
E) Alta con oxígeno domiciliario

PREGUNTA 18 2.01.2.024

**18. Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 mi- nuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial nor- males, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar punción lumbar
B) Iniciar diazepam
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
D) Iniciar ácido valproico
E) Mantener en observación por 4 horas

## BLOQUE 2 RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS

PREGUNTA 19 2.01.1.038

**19. Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Niño sano
B) Atresia duodenal
C) Constipación funcional
D) Megacolon aganglionótico
E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 20 2.01.1.076

**20. Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:**

A) Talla baja familiar
B) Hipogonadismo
C) Acondroplasia
D) Enanismo
E) Retardo constitucional del crecimiento

PREGUNTA 21 2.01.1.111

**21. Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Administrar propanolol
B) Administrar betametasona
C) Realizar embolización
D) Derivar a cirujano plástico
E) Observar evolución

PREGUNTA 22 2.01.2.004

**22. [URGENCIA: Compromiso de conciencia · 2.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Compromiso de conciencia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 23 2.01.2.011

**23.** **Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, que es mayor en las mañanas y se asocia a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios en el último tiempo, que han aumentado su frecuencia. ¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?**

A) Migraña de presentación atípica
B) Cefalea tensional
C) Jaqueca clásica
D) Vicio de refracción
E) Hipertensión endocraneana

PREGUNTA 24 2.01.2.017

**24.** **Un niño de 24 meses es traído por episodios repetidos de llanto, apnea, seguidos de hipotonía y compromiso de conciencia, que luego se recuperan espontáneamente. En algunos de estos episodios, además, presentó movimientos clónicos, de corta duración. Los episodios se han presentado en relación a situaciones en las que ha llorado o se ha enojado mucho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar TAC de cerebro y electroencefalograma
B) Iniciar ácido valproico
C) Solicitar electroencefalograma
D) Iniciar carbamazepina
E) Indicar manejo conductual

PREGUNTA 25 2.01.2.026

**25.** **[URGENCIA: Traumatismo encéfalo- craneano · 2.01.2.026] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo encéfalo- craneano. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 26 2.01.2.002

**26.** **Un niño de 18 meses consulta en el Servicio de Urgencia por disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio en reposo de 4 horas de evolución. Se cataloga como laringitis aguda grado II. Se administra dexametasona oral y una nebulización con adrenalina racémica, logrando una rápida mejoría sintomática con desaparición del estridor a los 20 minutos. ¿Cuál es la conducta médica correcta respecto al destino del paciente?**

A) Alta inmediata a domicilio con amoxicilina oral
B) Mantener en observación en el Servicio de Urgencia por un mínimo de 2 horas para descartar efecto rebote
C) Hospitalización inmediata en UCI pediátrica
D) Indicar nueva nebulización con adrenalina cada 30 minutos de forma reglada
E) Alta con indicación de frío ambiental e inhalador de salbutamol

PREGUNTA 27 2.01.1.015

**27.** **Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm3, 20 glóbulos blancos por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Oseltamivir
B) Vancomicina
C) Ceftriaxona
D) Aciclovir
E) Ampicilina

PREGUNTA 28 2.01.1.027

**28.** **Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Solución salina intranasal
B) Amoxicilina oral
C) Corticoides nasales
D) Diclofenaco oral
E) Azitromicina oral

PREGUNTA 29 2.01.2.003

**29.** **Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar PCR para Bordetella pertusis
B) Solicitar TAC de tórax
C) Solicitar broncoscopía
D) Realizar laringoscopía rígida
E) Iniciar antibióticos

PREGUNTA 30 2.01.2.018

**30.** **[URGENCIA: Obstrucción de vía aérea superior · 2.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Obstrucción de vía aérea superior. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 31 2.01.2.019

**31.** **Usted evalúa a un recién nacido de término, con antecedente de síndrome de Down, quien, desde el segundo día de vida, presenta vómitos abundantes y explosivos, que impiden su adecuada alimentación. Al examen físico se observa irritable, con distensión abdominal, por lo que se solicita radiografía abdominal que muestra imagen de doble burbuja, siendo de mayor tamaño la burbuja del lado izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atresia yeyunal
B) Atresia duodenal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Estenosis hipertrófica del píloro
E) Malrotación intestinal

PREGUNTA 32 2.01.1.009

**32.** **Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (http://www.childnurture.com/article/XXXXXXX) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción alérgica a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Síndrome de piel escaldada

PREGUNTA 33 2.01.1.011

**33.** **Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447§ionid=40442582). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Virus herpes simplex
B) Streptococcus pyogenes
C) Virus varicela zóster
D) Virus pox
E) Staphilococcus aureus

PREGUNTA 34 2.01.1.024

**34.** **Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucupurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior**

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Chlamydia pneumoniae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Staphilococcus aureus

PREGUNTA 35 2.01.1.062

**35.** **Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Ciprofloxacino
B) Cefadroxilo
C) Nitrofurantoína
D) Gentamicina
E) Cefoperazona

PREGUNTA 36 2.01.2.025

**36.** **[URGENCIA: Testículo agudo · 2.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Testículo agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 37 2.01.1.007

**37.** **Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Parasitológico de deposiciones
B) Test de Graham
C) Hemograma
D) Prueba de reacción cutánea a la escoriación (Prick test)
E) Recuento de inmunoglobulina E específica

PREGUNTA 38 2.01.1.023

**38.** **Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:**

A) Staphilococcus aureus
B) Streptococcus pyogenes
C) Metaneumovirus
D) Adenovirus
E) Virus de Ebstein Baar

PREGUNTA 39 2.01.1.029

**39.** **Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen Fsico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar radiogra:a de senos paranasales
B) Iniciar amoxicilina vía oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Iniciar prednisona oral
E) Solicitar nasofibroscopía

PREGUNTA 40 2.01.1.054

**40.** **Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:**

A) Soplo inocente
B) Ductus arterioso persistente
C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica

PREGUNTA 41 2.01.1.073

**41.** **Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?**

A) Suero glucosado
B) Suerlo glucosalino
C) Solución salina al 0,45%
D) Solución salina al 0,9%
E) Suloción ringer lactato

PREGUNTA 42 2.01.1.074

**42.** **Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:**

A) Vancomicina
B) Noradrenalina
C) Hidrocortisona
D) Vasopresina
E) Dopamina

PREGUNTA 43 2.01.1.108

**43.** **Lactante con eritema del pañal que no responde a óxido de zinc y muestra lesiones satélite. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Clotrimazol tópico
B) Mupirocina tópica
C) Hidrocortisona tópica 1%
D) Óxido de zinc en mayor concentración
E) Fluconazol oral

PREGUNTA 44 2.01.2.007

**44. [URGENCIA: Emergencia hipertensiva · 2.01.2.007] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Emergencia hipertensiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 45 2.01.2.012

**45. [URGENCIA: Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar · 2.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 46 2.01.2.020

**46. [URGENCIA: Paro cardiorrespiratorio · 2.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorrespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 47 2.01.1.008

**47. Pregunta 96 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen físico, está febril, con temperatura de 38.7°C, faringe eritematosa. Tiene adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y la piel se palpa áspera al tacto. ¿Qué tipo de complicación puede desarrollar este paciente?**

A) Aneurismas coronarios

B) Meningitis

C) Fasceítis necrotizante

D) Glomerulonefritis

E) Miocarditis

PREGUNTA 48 2.01.1.058

**48. Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Kawasaki

B) Mononucleosis infecciosa

C) Escarlatina

D) Artritis idiopática juvenil

E) Sarampión

PREGUNTA 49 2.01.1.039

**49. Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
B) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
C) Iniciar metronidazol oral
D) Iniciar ceftriaxona endovenosa
E) Iniciar vancomicina endovenosa

PREGUNTA 50 2.01.1.067

**50. Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm3, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome nefrótico
B) Púrpura de Schönlein Henoch
C) Insuficiencia renal prerrenal
D) Glomerulonefritis aguda posestreptocócica
E) Síndrome hemolítico urémico

PREGUNTA 51 2.01.1.046

**51. Un niño de 28 días presenta vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y que han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, observándose algo enflaquecido. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia duodenal
D) Colonoscopía con biopsia de la pared intestinal
E) Radiografía simple toracoabdominal

PREGUNTA 52 2.01.2.006

**52. Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardiaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
B) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
C) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
D) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
E) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

PREGUNTA 53 2.01.1.081

**53. Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síncompes vasovagales
B) Epilepsia mioclónico
C) Crisis de ausencia
D) Epilepsia focal
E) Déficit atencional

PREGUNTA 54 2.01.1.025

**54. Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Laringitis aguda obstructiva
B) Neumonía atípica
C) Neumonía bilateral
D) Asma del lactante
E) Neumonitis viral

## BLOQUE 4 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 55 2.01.1.010

**55. Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose pruri- to y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hepatitis crónica
B) Remisión completa
C) Portación asintomática del virus
D) Remisión parcial con recurrencias
E) Falla hepática

PREGUNTA 56 2.01.1.030

**56.** **Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Bartonella henselae
B) Toxoplasma gondii
C) Epstein-Barr virus
D) Mycobacterium tuberculosis
E) Leishmania sp.

PREGUNTA 57 2.01.1.043

**57.** **Un lactante de 9 meses de edad presenta cuadro de irritabilidad y llanto, asociado a un episodio de deposiciones con sangre roja abundante hace 3 horas. Al examen Fsico, está irritable y llora desconsoladamente a la palpación abdominal. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

A) TAC de abdomen y pelvis
B) Colonoscopía
C) Endoscopía diges2va alta
D) Cin2gra:a con tecnecio 99m
E) Radiogra:a de abdomen simple

PREGUNTA 58 2.01.1.055

**58.** **Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras introducción de fórmula láctea. Test de parche positivo para proteína de leche de vaca. ¿Cuál es el manejo?**

A) Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
B) Continuar fórmula habitual y agregar antihistamínico
C) Hospitalizar para estudio endoscópico
D) Iniciar corticoides orales
E) Cambiar a leche de soja

PREGUNTA 59 2.01.1.056

**59.** **Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?**

A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B) Déficit de complemento
C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E) Enfermedad granulomatosa crónica

PREGUNTA 60 2.01.1.057

**60.** **Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:**

A) Artritis reumatoide juvenil
B) Distrofia muscular
C) Dermatomiositis
D) Triquinosis
E) Lupus infantil

PREGUNTA 61 2.01.1.116

**61.** **Un recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, siendo alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de dos días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea obje8vada por la sonda. Se solicita radiograFa simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intes8nales, con zonas de engrosamiento de la pared intes8nal y visualización de burbujas en algunos segmentos. Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar resolución quirúrgica inmediata
B) Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasoenteral
C) Administrar an2bió2cos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Realizar endoscopía diges2va alta
E) Alimentar con suero glucosado por vía oral

PREGUNTA 62 2.01.1.127

**62.** **RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. ¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?**

A) Citomegalovirus (CMV)
B) Toxoplasma gondii
C) Virus herpes simplex tipo 2
D) Treponema pallidum
E) Virus de rubéola

PREGUNTA 63 2.01.1.133

**63.** **Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
D) Administrar prostaglandina
E) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

PREGUNTA 64 2.01.2.008

**64. [URGENCIA: Epistaxis · 2.01.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Epistaxis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 65 2.01.2.014

**65. Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?**

A) AINES
B) Benzodiacepinas
C) Salicilatos
D) Opiáceos
E) Antidepresivos tricíclicos

PREGUNTA 66 2.01.2.021

**66. [URGENCIA: Politraumatismos · 2.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Politraumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 67 2.01.1.018

**67. Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de an8piré8cos. Al examen Fsico se palpa una adenopa`a cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecograFa abdominal que muestra múl8ples lesiones hipoecogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compa8bles con microabscesos, sin pared visible. ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?**

A) Citomegalovirus
B) Virus de Epstein-Barr
C) Bartonella henselae
D) Echinococcus granulosus
E) Mycobacterium tuberculosis

PREGUNTA 68 2.01.1.026

**68. Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopía se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:**

A) Ibuprofeno oral
B) Amoxicilina oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Gentamicina tópica
E) Claritromicina oral

PREGUNTA 69 2.01.1.128

**69. Recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g). ¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?**

A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
C) Ayuno 6 horas y luego fórmula de prematuro
D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
E) Suero glucosado al 10% endovenoso

PREGUNTA 70 2.01.1.121

**70. Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Ictericia por lactancia materna

PREGUNTA 71 2.01.1.013

**71. Niño con fiebre de 10 días, cefalea, mialgias, diarrea y luego heces duras, hígado y bazo palpables. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar estudio?**

A) Coproparasitológico seriado
B) Coprocultivo
C) Serología para Epstein-Barr
D) Hemocultivo
E) Prueba de Widal

PREGUNTA 72 2.01.1.093

**72. Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho, de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39ºC. Al examen físico, se observa codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A) Staphilococcus aureus
B) Haemophilus influenzae
C) Streptococcus agalactiae
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

## BLOQUE 5 NEONATOLOGÍA & SALA DE PARTOS

PREGUNTA 73 2.01.1.001

**73. Un niño de 5 años presenta bajo incremento ponderal, con talla y peso menores a -1 desviación estándar para su edad. Se observa una radiografía de mano, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Raquitismo
B) Displasia ósea
C) Osteogénesis imperfecta
D) Osteomalacia
E) Osteoporosis

PREGUNTA 74 2.01.1.006

**74. Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre re- fiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?**

A) Amoxicicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

PREGUNTA 75 2.01.1.016

**75. Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Escarlatina
B) Mononucleosis infecciosa
C) Alergia a la penicilina
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Sarampión

PREGUNTA 76 2.01.1.031

**76. Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, plaquetas: 450.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Anemia ferropriva
B) Anemia por enfermedades crónicos
C) Trombocitosis esencial
D) Hemoglobinopatía
E) Microesferocitosis familiar

PREGUNTA 77 2.01.1.042

**77. Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A) Enfermedad celiaca
B) Enteropatía perdedora de proteínas
C) Enfermedad de cilio inmóvil
D) Fibrosis quística
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

PREGUNTA 78 2.01.1.088

**78. Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a urología de inmediato
B) Control en un mes
C) Iniciar testosterona tópica
D) Derivar a genética para cariotipo urgente
E) Cirugía correctiva a los 3 meses

PREGUNTA 79 2.01.1.096

**79. Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar a oftalmólogo
B) Mantener los controles habituales del lactante
C) Solicitar RMN de cerebro
D) Realizar fondo de ojo
E) Indicar parche ocular alternante

PREGUNTA 80 2.01.1.105

**80. Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tie- ne otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?**

A) Hipercolesterolemia
B) Hipertrigliceridemia
C) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
D) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
E) Un componente de la dieta

PREGUNTA 81 2.01.1.107

**81. Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Derma22s alérgica
B) Ur2caria
C) Derma22s atópica
D) Escabiosis
E) Derma22s seborreica

PREGUNTA 82 2.01.1.109

**82. Una prescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ivermectina oral
B) Permetrina tópica al 1%
C) Permetrina tópica al 5%
D) Lindano tópico
E) No tratar, mientras no se visualicen piojos

PREGUNTA 83 2.01.1.131

**83. Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tie- ne desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:**

A) Realizar lavados con ácido acéticos
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Indicar antibióticos
E) Realizar aseo y masajes en la zona

PREGUNTA 84 2.01.2.015

**84. Lactante de 3 meses con fiebre 39°C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar, punción lumbar y ATB empírico EV inmediato (ampicilina + cefotaxima)
B) ATB oral y control en 24h
C) Solo antipiréticos y observar
D) Solicitar TAC antes de la punción lumbar
E) Alta con instrucciones

PREGUNTA 85 2.01.2.022

**85. Usted atiende a un niño de 3 años en el servicio de urgencia, que es traído por su madre, por haber sufrido quemaduras en los dedos y en la espalda, después de haberse apoyado accidentalmente en una estufa. Al examen físico, está agitado y llorando y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. ¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Curaciones
B) Paracetamol vía oral
C) Ungüento antibiótico tópico
D) Analgesia endovenosa
E) Antibióticos endovenosos

PREGUNTA 86 2.01.2.027

**86. [URGENCIA: Estatus convulsivo en el niño · 2.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Estatus convulsivo en el niño. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 87 2.01.1.036

**87. Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Hemofilia
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Enfermedad de Glanzmann
E) Púrpura trombocitopénica trombótica

PREGUNTA 88 2.01.2.009

**88. Un recién nacido de 38 semanas, con peso de 4.250 g, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta temblores finos en extremidades superiores y succión débil a las 2 horas de vida. Se realiza control de glicemia venosa que informa 32 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Ofrecer mamadera de 20 mL de agua con azúcar por vía oral y reevaluar en 2 horas
B) Administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% a 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua de glucosa a 6-8 mg/kg/min
C) Administrar un bolo endovenoso rápido de Suero Glucosado al 50% a 5 mL/kg
D) Administrar Hidrocortisona endovenosa a 10 mg/kg como primera línea
E) Mantener en observación sin tratamiento, dado que a las 2 horas la glicemia de 32 mg/dL es normal

PREGUNTA 89 2.01.1.075

**89. Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). La conducta más adecuada es:**

A) Suspender la levotiroxina
B) Subir la dosis de levotiroxina
C) Repetir la TSH en 6 semanas
D) Disminuir la dosis de levotiroxina
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

PREGUNTA 90 2.01.1.069

**90. Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis aguda
C) Insuficiencia renal crónica
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Nefritis intersticial

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO & VACUNAS PNI · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 — Respuesta: D — Leucemias

2.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 85). Evalúa el manejo clínico de Leucemias según directrices MINSAL vigentes.

### PREGUNTA 2 — Respuesta: D — Tumores sólidos

2.01.1.037 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La asociación de hematuria y masa obliga a descartar un tumor de Wilms o nefroblastoma, el cáncer renal más frecuente en niños (en adultos lo más frecuente es el cáncer de células renales).

### PREGUNTA 3 — Respuesta: A — Cardiopatías congénitas frecuentes

2.01.1.050 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

### PREGUNTA 4 — Respuesta: C — Hemorragia digestiva

2.01.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un Sd. De Mallory Weiss clásico

### PREGUNTA 5 — Respuesta: A — Meningococcemia

2.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Meningococcemia" como urgencia clínica (2.01.2.016), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

### PREGUNTA 6 — Respuesta: A — Shock

2.01.2.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Manejo de Sepsis en Lactantes: En casos de sepsis en lactantes, la prioridad es la reanimación y la administración de antibióticos. Si el lactante presenta shock o signos de deshidratación, la primera medida es la hidratación intravenosa con solución salina.

### PREGUNTA 7 — Respuesta: B — SARS Cov 2 COVID 19

2.01.2.144 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36). Evalúa el manejo clínico de SARS Cov 2 COVID 19 según directrices MINSAL vigentes.

### PREGUNTA 8 — Respuesta: A

2.01.1.072 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

**Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)**

Tiene una pubertad precoz (menos de 9 años en varones), con testículos de 4 cc, por lo que están estimulados por las gonadotropinas. Como hay elevación de gonadotropinas, es porque está activado el eje hipotálamo hipófisis, es decir, es central.

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

**Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)**

2.01.1.141 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: C**

**Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)**

2.01.1.083 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La caminata en punta de pies puede tener múltiples causas, siendo normal en menores de 3 años, pero también asociándose a trastornos del espectro autista (se `pensaría si tuviese otras estereotipias, alteraciones del lenguaje o de la interacción social) y se asocia asimismo a parálisis cerebral con espasticidad. La diplejía espástica es una variante de ello, en que se afectan las extremidades inferiores. Tiene buen pronóstico con un adecuado tratamiento multidisciplinario. La distrofia muscular suele tener un desarrollo normal, pero luego va perdiendo fuerza, especialmente en los grupos musculares grandes, que, por ejemplo, le dificulta ponerse de pie, por lo que suele hacerlo con el apoyo de las manos.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

**Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026**

2.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Hexavalente, Hepatitis A y Varicela corresponden al hito de los 18 meses. B) Correcta. En Chile, a los 12 meses de vida se administran: 1) Tresvírica (SRP: sarampión, rubéola, parotiditis), 2) Meningocócica conjugada contra serogrupos A, C, W-135 e Y, y 3) Refuerzo de Neumocócica conjugada. C) Incorrecta. La varicela y el refuerzo de hexavalente se indican a los 18 meses. D) Incorrecta. La polio oral (bOPV) ya no forma parte del calendario chileno (se usa VIP en la hexavalente). E) Incorrecta. La varicela corresponde a los 18 meses.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: A**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es una bronquiolitis clásica, por VRS.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: A**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.048 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Se sospecha una enfermedad celíaca, que se estudia con anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomisio, más una endoscopía digestiva alta, con biopsia duodenal.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: E**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.095 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tanto gonococo como clamidia producen conjuntivitis neonatal, pero la gonorrea suele ser muy purulenta y aparecer en la primera semana de vida. La clamidia, en cambio, puede demorar más (algunas semanas), ser menos purulenta y asociarse a neumonía, similar a las neumonías atípicas.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: A**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Crisis asmática moderada: broncodilatadores β2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $SatO_2$ >94%.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Niño con neumonía grave que no responde a oxigenoterapia convencional + signos de trabajo respiratorio aumentado: siguiente escalón = VNI (CPAP o BPAP) antes de intubación, según protocolo actual.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: E**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.2.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Parece una comvulsión febril benigna. No tiene signos que hagan sospechar me- ningitis y por ser la primera convulsión, tampoco es necesario iniciar naticonvulsivantes.

---

## BLOQUE 2 RESPIRATORIO PEDIÁTRICO & URGENCIAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: C** **Constipación** 2.01.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: E** **Talla baja** 2.01.1.076 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un retraso constitucional del crecimiento. Edad ósea 2 años menor a la cronológica. Llama la atención los testículos pequeños (aún no inicia la pubertad, pero eso es acorde a su edad biológica = ósea), sin embargo el Klinefelter, no tiene talla baja. El Turner, de las niñas, sí tiene talla baja.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

**Malformaciones vasculares cutáneas**

2.01.1.111 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

El propanolol es el tratamiento de primera línea de los hemangiomas infantiles. La cirugía solo se hace en casos que no responden y sabiendo que dejará cicatriz con certeza.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A** **Compromiso de conciencia** 2.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Compromiso de conciencia" como urgencia clínica (2.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: E** **Hipertensión endocraneana** 2.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

No queda claro la causa precisa de sus síntomas (tumor cerebral, meningitis tuberculosa, pseudotumor cerebral), pero sí tiene un síndrome de HTEC clásico, con 1. la cefalea de predominio matinal, 2. las náuseas y vómitos y 3. solo le falta el edema de papila. La migraña y la cefalea tensional suelen aumentar en las tardes y no en las mañanas.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: E** **Muerte súbita-ALTE, BRUE** 2.01.2.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene apneas emotivas, que son ALTE de bajo riesgo. Orienta a eso la edad y la clara correlación con las emociones. Se observan y se educa. Los ALTE de alto riesgo, en cambio, son los que tienen menos de 6 meses, antecedentes de muerte súbita en la familia, alteraciones en el examen neurológico o cardiaco o la necesidad de reanimación.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A** **Traumatismo encéfalo- craneano** 2.01.2.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo encéfalo- craneano" como urgencia clínica (2.01.2.026), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona** 2.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El alta inmediata tras adrenalina es peligrosa por el riesgo de reaparición del edema al cesar la vasoconstricción alfa-1. B) Correcta. La adrenalina nebulizada produce vasoconstricción mucosa rápida pero transitoria (duración de 90 a 120 minutos). Existe el riesgo demostrado de 'efecto rebote', en el cual el estridor y la disnea reaparecen con igual o mayor intensidad. Por norma de seguridad pediátrica, todo niño que recibe adrenalina nebulizada debe permanecer en observación en Urgencia por un mínimo de 2 horas antes de definir el alta ambulatoria. C) Incorrecta. Si responde favorablemente y no tiene otros factores de riesgo, no requiere UCI. D) Incorrecta. La adrenalina se usa según necesidad clínica, no de forma profiláctica reglada cada 30 minutos. E) Incorrecta. El salbutamol no actúa en la vía aérea superior subglótica.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: D**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización** 2.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una meningitis herpética, que se trata con aciclovir EV. Tanto la clínica, como el LCR viral (predominio MN y glucosa normal) hemorrágico la sugieren.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

**Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización** 2.01.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un resfrío común. No aparecía paracetamol SOS, así que la respuesta más adecuada es el SF intranasal.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: C**

**Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía** 2.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Si bien el primer examen suele ser la radiografía, el manejo y extracción se realiza con broncoscopía flexible o rígida, según disponibilidad. La TAC no suele aportar mucho más que la radiografía y, sea como sea, la clínica tan categórica obliga a la broncoscopía.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: A**

**Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía** 2.01.2.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Obstrucción de vía aérea superior" como urgencia clínica (2.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

**Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía**

2.01.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Atresia Duodenal: La imagen de "doble burbuja" y el cuadro clínico apuntan a una atresia duodenal. La enterocolitis necrotizante sí puede tener vómitos, pero se manifestaría con antecedentes de prematurez o asfixia, heces con sangre y neumatosis intestinal en la radiografía. La estenosis hipertrófica del píloro, aunque presenta síntomas similares, suele aparecer más tarde, entre las 2 y 6 semanas de vida.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: E**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: C**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una NAC neumocócica clásica.

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.062 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: A**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.2.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Testículo agudo" como urgencia clínica (2.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

## BLOQUE 3 INFECCIONES, EXANTEMAS & DIGESTIVO PEDIÁTRICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: B** **Enteroparasitosis** 2.01.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Parece una oxiuriasis, que se diagnostica con el test de Graham.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: D** **Faringoamigdalitis** 2.01.1.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B** **Sinusitis** 2.01.1.029 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tiene una sinusiGs aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: A** **Soplos** 2.01.1.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: D** **Diabetes** 2.01.1.073 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La cetoacidosis se hidrata con suero fisiológico. Sin embargo la opción del Ringer Lactato es una respuesta totalmente correcta. Pero suero NaCl al 0,9% será la respuesta correcta.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: C** **Hiperplasia suprarrenal congénita** 2.01.1.074 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hiperplasia suprarrenal congénita, con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde). Además está descompensado, probablemente por una infección.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Dermatitis del pañal y de contacto** 2.01.1.108 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Clotrimazol tópico

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A** **Emergencia hipertensiva** 2.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Emergencia hipertensiva" como urgencia clínica (2.01.2.007), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar** 2.01.2.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar" como urgencia clínica (2.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: A** **Paro cardiorrespiratorio** 2.01.2.020 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorrespiratorio" como urgencia clínica (2.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: D**

**Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)** 2.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

La escarlatina se complica con GNAPE.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)**

2.01.1.058 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Kawasaki: fiebre ≥5 días + ≥4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, labios/lengua enrojecidos, edema palmoplantar). Requiere ecocardio y tratamiento con IGIV + aspirina para prevenir aneurismas coronarios.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: A**

**Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico**

2.01.1.039 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rotavirus con tolerancia oral y rehidratación oral..

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: E**

**Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico**

2.01.1.067 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

**Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal**

2.01.1.046 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: D**

**Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico**

2.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: C**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.081 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Cuadro clásico

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona**

2.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Laringitis Aguda Obstructiva: El caso describe una laringitis aguda obstructiva clásica, con un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, incluyendo estridor laringeo.

---

**PREGUNTA 55** **Respuesta: D** **Hepatitis viral** 2.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A).

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A** **Adenopatías** 2.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Bartonella henselae

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: D** **Hemorragia digestiva** 2.01.1.043 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

El cuadro clínico sugiere una intususcepción intestinal, cuyo examen de elección es la ecografía abdominal. Sin embargo, no está entre las opciones, por lo que lo más probable es que quien redactó la pregunta quería preguntar un diverVculo de Meckel complicado. El diverVculo de Meckel se estudia con cintigrafía con tecnecio 99m, también llamada “cintigrafía de Meckel”.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A** **Alergias** 2.01.1.055 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Alergia a proteína de leche de vaca (APLV): tratamiento = fórmula extensamente hidrolizada (FEH). Si se usa leche materna, la madre elimina lácteos. Soja no recomendada bajo 6 meses (cross-reactividad).

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: C** **Inmunodeficiencias** 2.01.1.056 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar

Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: C** **Mesenquimopatías** 2.01.1.057 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una dermatomiositis infantil clásica, con el rash heliotropo y el rash en manto. Se debe descartar un cáncer (suele ser paraneoplásica).

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: C** **Enterocolitis necrotizante (ECN)** 2.01.1.116 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una enterocoliGs necroGzante, confirmada por la radiografía, que muestra neumatosis intestinal. Su tratamiento consiste en régimen cero, descompresión gástrica mediante sonda, hidratación y alimentación parenteral, antibióticos de amplio espectro y analgesia, más manejo de las complicaciones. La cirugía se reserva a los casos complicados (perforación, estenosis) y a los muy graves que no responden al tratamiento médico. El suero oral y la alimentación por sonda enteral están contraindicados.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A** **TORCH** 2.01.1.127 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

CMV congénito es la infección congénita viral más frecuente. Calcificaciones periventriculares (vs parenquimatosas en toxoplasma) + microcefalia + coriorretinitis = TORCH por CMV.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: E**

**Malformaciones congénitas más frecuentes** 2.01.1.133 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A** **Epistaxis** 2.01.2.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Epistaxis" como urgencia clínica (2.01.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: A** **Intoxicaciones** 2.01.2.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: A** **Politraumatismos** 2.01.2.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Politraumatismos" como urgencia clínica (2.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: C**

**Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)**

2.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una enfermedad por arañazo de gato clásica, con la fiebre, adenopaVa y compromiso hepatoesplénico. Eso sí, la presentación más frecuente es con fiebre más una o más adenopaVas en relación a una lesión cutánea. La igM anti-Bartonella puede ser úGl para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de elección son los macrólidos (azitromicina).

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

**Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR**

2.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene una OMA: amoxi sola. En la OMAR también es amoxi sola. Solo si no responde en 72 horas, se agrega ácido clavulánico.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: D**

**Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal**

2.01.1.128 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

**Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia**

2.01.1.121 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una ictericia precoz (menor a 24 horas), indirecta, por lo que lo más probable es que sea hemolítica. Además, por los grupos sanguíneos, solo puede ser por incompatibilidad de grupo clásico (madre O e hijo A o B).

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: D**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Hemocultivo

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo**

2.01.1.093 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una artritis séptica de codo (monoartritis aguda en niño). La etiología más frecuente es el estafilococo áureo en todas las edades, ya que el gonococo ha disminuido mucho (eso sí, aún debe tenerse como opción en pacientes con conductas sexuales de riesgo o con clínica de gonorrea).

---

**PREGUNTA 73** **Respuesta: A** **Desnutrición** 2.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Raquitismo: La radiografía muestra un retraso severo en la calcificación de los huesos del carpo y otros huesos de la mano, lo que es compatible con raquitismo causado por deficiencia de vitamina D.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B** **Coqueluche** 2.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B** **Mononucleosis infecciosa** 2.01.1.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Es una mononucleosis clásica, dado que tiene el síndrome mononucleósico (odinofagia, fiebre y adenopatías), más el clásico rash morbiliforme (similar al sarampión), que aparece luego de iniciar aminopenicilinas (ampicilina o amoxicilina). También es clásico el exudado amigdalino blanco y adherente sobre la superficie amigdalina. La escarlatina tendría clínica de amigdalitis bacteriana (ya explicada en otra pregunta) y un exantema en piel de gallina, con especial afectación de pliegues cubitales y que respeta el triángulo de Filatov. La enfermedad de Kawasaki no suele tener odinofagia ni exudado amigdalino, sino fiebre, adenopatías, ojo rojo, boca roja, rash de cualquier tipo (salvo vesicular o pustular) y compromiso de pies y manos.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A** **Anemia ferropriva** 2.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad, como por la microcitosis.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: D** **Fibrosis quística** 2.01.1.042 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B** **Criptorquidia** 2.01.1.088 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Control en un mes

**PREGUNTA 79** **Respuesta: B** **Estrabismo** 2.01.1.096 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 115). Evalúa el manejo clínico de Estrabismo según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 80** **Respuesta: E** **Alteraciones pigmentarias** 2.01.1.105 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por ingesta de betacaroteno

**PREGUNTA 81** **Respuesta: C** **Dermatitis atópica** 2.01.1.107 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una dermaGGs atópica clásica: lesiones crónico recidivantes, en zonas flexoras, más mejillas.

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B** **Ectoparasitosis** 2.01.1.109 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Tanto los piojos, como las liendres, son diagnósticas de pediulosis (a menos que las liendres estén muy alejadas del cuero cabelludo, ya que serían antiguas). La pediculosis se trata con permetrina al 1%.

**PREGUNTA 83** **Respuesta: E** **Sinequias vulvares** 2.01.1.131 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Completo

Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferen- te. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuleva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A** **Meningitis bacteriana** 2.01.2.015 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Meningitis bacteriana en lactante <3 meses: hospitalización urgente + punción lumbar + ATB empírico inmediato (ampicilina para cubrir Listeria + cefotaxima para S. agalactiae, E. coli, S. pneumoniae).

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: D** **Quemaduras** 2.01.2.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 21). Evalúa el manejo clínico de Quemaduras según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: A** **Estatus convulsivo en el niño** 2.01.2.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Estatus convulsivo en el niño" como urgencia clínica (2.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: B**

**Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato** 2.01.1.036 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

El alargamiento del TTPA sugiere fuertemente hemofilia. Que tenga una clínica tan florida, en un niño (sexo masculino) pequeño, la sugiere también. Suele evolucionar a hemartrosis y hematomas musculares y de otras partes del cuerpo. PTI y PTT tienen plaquetopenia. EvW y Glanzmann tienen alteración de la hemostasia primaria, con petequias y clínicas generalmente más leves que la hemofilia, aunque sí pueden tener una clínica similar, en las formas más graves. Eso sí, el TTPA suele estar normal, salvo en algunas variantes de la EvW en que sí se puede alargar.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: B**

**Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato** 2.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. En un paciente sintomático, la vía oral no asegura corrección rápida ni previene el daño cerebral. B) Correcta. La hipoglicemia neonatal sintomática (temblores, glicemia < 45 mg/dL) es una urgencia neurológica. El tratamiento protocolizado consiste en administrar un bolo endovenoso de Suero Glucosado al 10% (SG10%) a dosis de 2 mL/kg (200 mg/kg de glucosa) infundido lentamente en 5 minutos, seguido inmediatamente de una infusión continua de glucosa para mantener una carga (VIG) de 6 a 8 mg/kg/minuto, reevaluando la glicemia plasmática en 30 minutos. C) Incorrecta. El SG al 50% o al 20% en bolo está formalmente contraindicado por riesgo de lesión endotelial, hiperosmolaridad cerebral y secreción masiva de insulina que produce hipoglicemia de rebote grave. D) Incorrecta. Los corticoides se reservan para hiperinsulinismo refractario extremo. E) Incorrecta. 32 mg/dL con temblores es francamente patológico.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: D**

**Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo** 2.01.1.075 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene la TSH menor a lo normal, por lo que está “sobretratado” y se debe disminuir la dosis de levoT4. La habitual es 1,6 ug/Kg, así que probablemente estaba muy alta la dosis de 25 mg para un lactante de 3 meses (6 Kg aprox).

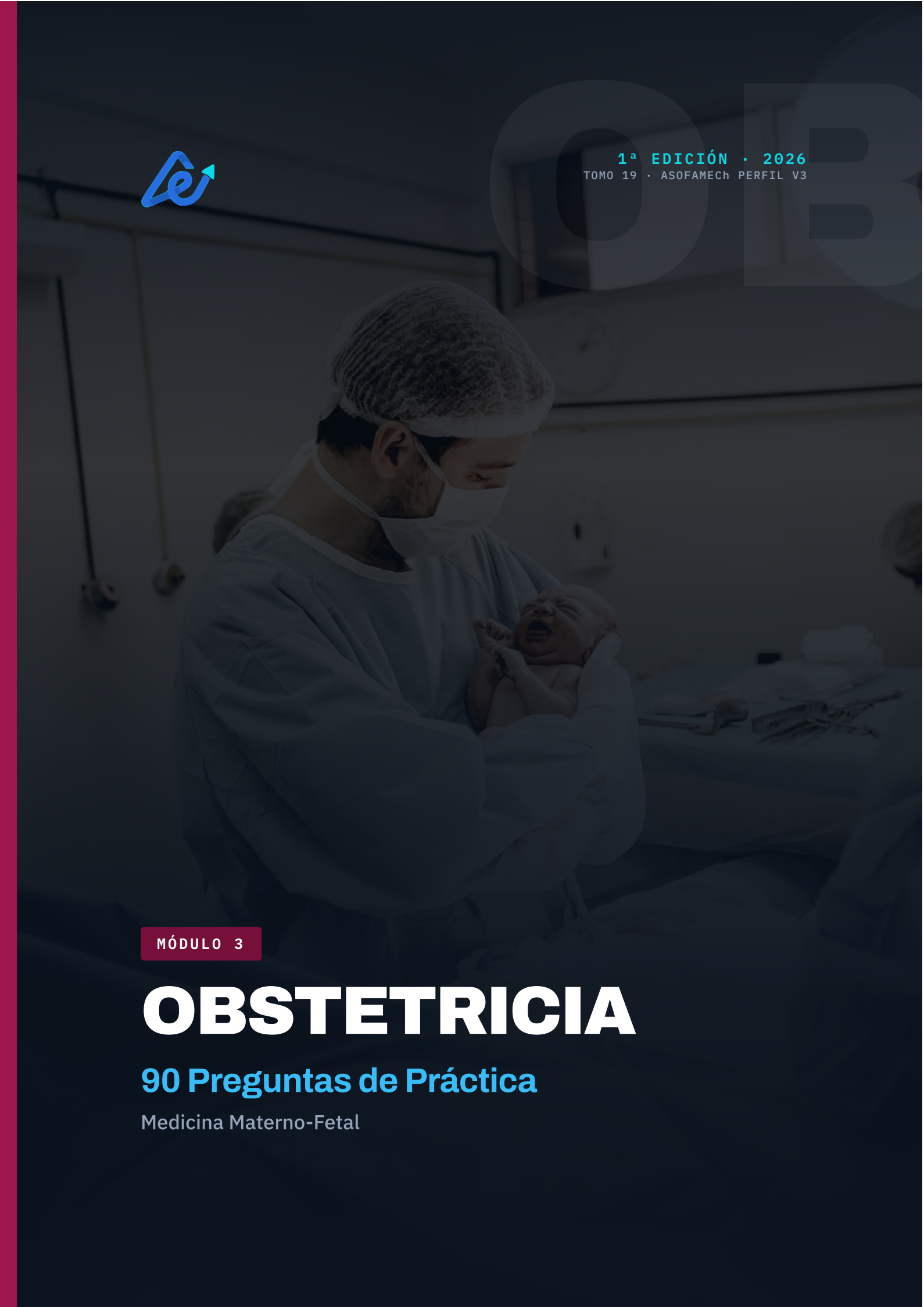
---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado**

2.01.1.069 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.



1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 19 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 3

# OBSTETRICIA

## 90 Preguntas de Práctica

Medicina Materno-Fetal

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Obstetricia · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL** | | | | | |
| 3.01.1.010 | Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18 | Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11) |
| 3.01.1.031 | VIH en ginecobstetricia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.017 | Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q2 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.3.001 | Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3, Q4 | Tomo 19 · 19.1 (Pág. 5) |
| 3.01.4.003 | Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5, Q6 | Tomo 19 · 19.2 (Pág. 7) |
| 3.01.5.009 | Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7, Q8 | Tomo 19 · 19.3 (Pág. 9) |
| **BLOQUE 2: PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO** | | | | | |
| 3.01.1.003 | Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35, Q36 | Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28) |
| 3.01.1.004 | Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29, Q30, Q31, Q32, Q33 | Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24) |
| 3.01.1.011 | Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q20, Q21, Q22 | Tomo 19 · 19.5 (Pág. 18) |
| 3.01.2.003 | Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q23 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.004 | Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27, Q28 | Tomo 19 · 19.6 (Pág. 20) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | HELLP y Sulfato de Magnesio | | | | |
| 3.01.2.007 | Hiperemesis gravídica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q19 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO** | | | | | |
| 3.01.1.001 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 | Tomo 19 · 19.10 (Pág. 35) |
| 3.01.1.002 | Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 19 · 19.11 (Pág. 39) |
| 3.01.1.003 | Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52 | Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28) |
| 3.01.1.019 | Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q53, Q54 | Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30) |
| 3.01.2.001 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.005 | Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q50 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.010 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q44 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.013 | Presentaciones fetales anómalas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO** | | | | | |
| 3.01.1.004 | Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q55, Q56, Q57, Q58 | Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24) |
| 3.01.1.005 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q61, Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 19 · 19.14 (Pág. 52) |
| 3.01.1.006 | Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68, Q69, Q70 | Tomo 19 · 19.15 (Pág. 56) |
| 3.01.1.007 | Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 19 · 19.16 (Pág. 60) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.2.011 | Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.012 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 19 · C.38 (Pág. 80) |
| 3.01.2.014 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67 | Tomo 20 · C.40 (Pág. 84) |
| 3.01.2.015 | Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q60 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.021 | Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q72 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| **BLOQUE 5: PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS** | | | | | |
| 3.01.1.008 | Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 19 · 19.17 (Pág. 62) |
| 3.01.1.009 | Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 19 · 19.18 (Pág. 66) |
| 3.01.1.010 | Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q85, Q86 | Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11) |
| 3.01.1.012 | Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 19 · 19.20 (Pág. 72) |
| 3.01.2.006 | Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.009 | Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q88 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Obstetricia · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.1.001 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 | Tomo 19 · 19.10 (Pág. 35) |
| 3.01.1.002 | Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 19 · 19.11 (Pág. 39) |
| 3.01.1.003 | Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34, Q35, Q36, Q51, Q52 | Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28) |
| 3.01.1.004 | Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q55, Q56, Q57, Q58 | Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24) |
| 3.01.1.005 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q61, Q62, Q63, Q64, Q65 | Tomo 19 · 19.14 (Pág. 52) |
| 3.01.1.006 | Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68, Q69, Q70 | Tomo 19 · 19.15 (Pág. 56) |
| 3.01.1.007 | Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q71 | Tomo 19 · 19.16 (Pág. 60) |
| 3.01.1.008 | Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79 | Tomo 19 · 19.17 (Pág. 62) |
| 3.01.1.009 | Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q80, Q81, Q82, Q83, Q84 | Tomo 19 · 19.18 (Pág. 66) |
| 3.01.1.010 | Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q85, Q86 | Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11) |
| 3.01.1.011 | Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q20, Q21, Q22 | Tomo 19 · 19.5 (Pág. 18) |
| 3.01.1.012 | Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti- | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 19 · 19.20 (Pág. 72) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | D y Manejo de la Gestante Sensibilizada | | | | |
| 3.01.1.019 | Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q53, Q54 | Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30) |
| 3.01.1.031 | VIH en ginecobstetricia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.001 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.003 | Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q23 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.004 | Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q24, Q25, Q26, Q27, Q28 | Tomo 19 · 19.6 (Pág. 20) |
| 3.01.2.005 | Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q50 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.006 | Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q87 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.007 | Hiperemesis gravídica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q19 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.009 | Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q88 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.010 | Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q44 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.011 | Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q59 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.012 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q66 | Tomo 19 · C.38 (Pág. 80) |
| 3.01.2.013 | Presentaciones fetales anómalas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.014 | Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q67 | Tomo 20 · C.40 (Pág. 84) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Antibiótica y Corioamnionitis | | | | |
| 3.01.2.015 | Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q60 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.017 | Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q2 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.021 | Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q72 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.3.001 | Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q3, Q4 | Tomo 19 · 19.1 (Pág. 5) |
| 3.01.4.003 | Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5, Q6 | Tomo 19 · 19.2 (Pág. 7) |
| 3.01.5.009 | Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q7, Q8 | Tomo 19 · 19.3 (Pág. 9) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

PREGUNTA 1 3.01.1.031

**1. Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?**

A) Iniciar triterapia antirretroviral ahora
B) Realizar cesárea ahora
C) Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta
D) Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto
E) Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

PREGUNTA 2 3.01.2.017

**2. Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza fetal ascendida, 2 centímetros por sobre las espinas isquiáticas. Presenta dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, recibiendo goteo oxitócico. Luego de 2 horas de observación no se presentan cambios en las condiciones obstétricas y, poco después, aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender oxitocina, lateralizar y controlar por 30 minutos
B) Realizar operación cesárea de inmediato
C) Administrar anestesia epidural y conducir el trabajo de parto
D) Aumentar la dosis de oxitocina y, una vez que se logre el descenso de la cabeza, realizar fórceps
E) Solicitar ecografía Doppler fetal

PREGUNTA 3 3.01.3.001

**3. Una mujer de 26 años con antecedente de un hijo previo nacido con mielomeningocele lumbosacro planifica un nuevo embarazo. Acude a consulta preconcepcional para orientación médica. ¿Cuál es la indicación de suplementación con ácido fólico recomendada para reducir el riesgo de recurrencia de defectos del tubo neural?**

A) 0.4 mg al día iniciando al confirmar el test de embarazo positivo en orina
B) 4.0 a 5.0 mg al día por vía oral, iniciado al menos 3 meses antes de la concepción y mantenido hasta las 12 semanas de gestación
C) 1.0 mg al día durante todo el segundo y tercer trimestre exclusivamente
D) 10 mg semanales en inyección intramuscular única
E) No requiere suplementación si consume cereales y harinas fortificadas

PREGUNTA 4 3.01.3.001

**4. Una primigesta de 36 semanas de gestación acude a control prenatal habitual en APS. Se revisa el resultado del cultivo vaginorrectal tomado a las 35 semanas, el cual informa: desarrollo abundante de Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B). La paciente se encuentra totalmente asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) Indicar Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días de inmediato para erradicar la bacteria
B) Realizar cesárea electiva de urgencia para evitar el paso del feto por el canal vaginal
C) Consignar el resultado en el carné prenatal e indicar que recibirá Penicilina G endovenosa durante el trabajo de parto activo
D) Indicar óvulos vaginales de Metronidazol por 10 noches
E) Repetir el cultivo vaginorrectal cada semana hasta que resulte negativo

PREGUNTA 5 3.01.4.003

**5. A una primigesta de 12 semanas se le realiza la ecografía de primer trimestre. Se constata Doppler de arterias uterinas patológico con un Índice de Pulsatilidad medio superior al percentil 95. ¿Cuál es la intervención preventiva con mayor evidencia para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia severa y restricción de crecimiento fetal?**

A) Reposo absoluto en cama en decúbito lateral izquierdo
B) Iniciar Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 150 mg al día por vía oral antes de las 16 semanas
C) Iniciar Enoxaparina subcutánea a dosis de anticoagulación plena
D) Dieta hiposódica estricta sin sal y diuréticos tiazídicos
E) Prescribir Nifedipino oral como antihipertensivo profiláctico

PREGUNTA 6 3.01.4.003

**6. Durante la ecografía morfológica de las 22 semanas en una paciente asintomática sin antecedentes mórbidos, se realiza cervicometría transvaginal que informa una longitud endocervical cerrada de 18 mm. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada para prevenir el parto prematuro?**

A) Cerclaje cervical de emergencia inmediato
B) Indicar Progesterona natural micronizada por vía vaginal a 200 mg diarios cada noche hasta la semana 36
C) Hospitalización e inicio de tocolíticos orales con nifedipino profiláctico
D) Indicar reposo domiciliario relativo sin medicamentos
E) Instalación de pesario cervical sin progesterona

PREGUNTA 7 3.01.5.009

**7. Se realiza un Registro Basal No Estresante (RBNE) a una embarazada de 37 semanas por disminución transitoria de movimientos fetales. En los primeros 20 minutos de trazado se observa: FCF basal de 130 lpm, variabilidad de 8 lpm, ausencia de aceleraciones y ausencia de desaceleraciones. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A) Indicar cesárea de urgencia por sufrimiento fetal agudo
B) Prolongar el registro por 20 minutos adicionales y aplicar estímulo acústico o táctil al feto para descartar ciclo de sueño fisiológico
C) Hospitalizar en UCI de adultos para infusión de sulfato de magnesio
D) Considerar el examen 100% normal y dar el alta definitiva sin más controles
E) Administrar un bolo de 1.000 mL de suero fisiológico y realizar amniocentesis

PREGUNTA 8 3.01.5.009

**8. En una paciente de 36 semanas con sospecha de deterioro de la función placentaria se realiza un Perfil Biofísico Fetal ecográfico de Manning. Se obtienen los siguientes resultados: sin movimientos respiratorios en 30 min (0 pts), 1 movimiento corporal único (0 pts), tono flexor conservado (2 pts), líquido amniótico con bolsillo vertical máximo de 0.8 cm (0 pts) y RBNE no reactivo (0 pts). Puntaje total: 2/10. ¿Cuál es la conducta clínica indicada?**

A) Repetir el examen en 48 horas en forma ambulatoria
B) Interrupción inmediata del embarazo por riesgo crítico de asfixia y óbito fetal
C) Indicar reposo en cama e hidratación oral con abundante agua
D) Administrar betametasona y diferir el parto por al menos 5 días
E) Iniciar antibióticos profilácticos orales y control semanal

PREGUNTA 9 3.01.1.010

**9. Una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en el percentil 2, desde la semana 33, con Doppler fetal normal, en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler fetal de control, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:**

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Solicitar perfil biofísico
D) Controlar semanalmente con el Doppler
E) Interrumpir a las 37 semanas

PREGUNTA 10 3.01.1.010

**10. Una embarazada de 33 semanas de gestación se realiza ecografía que muestra una Estimación de Peso Fetal en el percentil 6. La velocimetría Doppler revela: arteria umbilical con Índice de Pulsatilidad normal (< P95), arteria cerebral media normal (> P5) y arterias uterinas normales. El líquido amniótico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado y la conducta a seguir?**

A) Restricción de crecimiento fetal severa; indicar cesárea inmediata
B) Pequeño para la edad gestacional constitucional (PEG); mantener controles habituales y programar parto a término (39-40 semanas)
C) Restricción de crecimiento fetal etapa II; hospitalizar e inducir el parto a las 34 semanas
D) Sufrimiento fetal agudo; realizar amniocentesis diagnóstica
E) Feto adecuado para la edad gestacional normal

PREGUNTA 11 3.01.1.010

**11. En el seguimiento Doppler de un feto de 30 semanas con restricción de crecimiento fetal severa, se pesquisa la presencia de flujo reverso persistente durante la sístole auricular (onda 'a' reversa) en el Ductus Venoso. ¿Cuál es el significado fisiopatológico y la conducta médica inmediata?**

A) Signo de madurez pulmonar avanzada; alta a domicilio
B) Signo de falla miocárdica y acidosis metabólica fetal crítica; interrupción inmediata del embarazo por cesárea bajo neuroprotección con sulfato de magnesio
C) Variante anatómica benigna sin repercusión hemodinámica
D) Indicar infusión de glucosa materna para revertir la onda 'a'
E) Programar nuevo control ecográfico en 2 semanas

PREGUNTA 12 3.01.1.010

**12. Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar registro basal no estresante
C) Observar evolución
D) Realizar doppler materno fetal
E) Realizar operación cesárea

PREGUNTA 13 3.01.1.010

**13. Una paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de RCIU en percentil 3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es una indicación de interrupción inmediata del embarazo?**

A) Oligohidroamnios
B) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C) Dilatación de la arteria cerebral media
D) Relación femoro/abdominal mayor a 0,25
E) Ducto venoso con flujo ausente en diástole, al doppler

PREGUNTA 14 3.01.1.010

**14. Una paciente multípara, de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. ¿Cuál es la actitud más adecuada?**

A) Observar evolución
B) Solicitar ecodoppler uterina
C) Solicitar ecodoppler umbilical
D) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
E) Inducir maduración pulmonar con corticoides

PREGUNTA 15 3.01.1.010

**15.** **Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar perfil biofísico
B) Administrar corticoides
C) Interrumpir a las 37 semanas
D) Realizar cesárea en este momento
E) Continuar el control semanal con Doppler

PREGUNTA 16 3.01.1.010

**16.** **Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar registro basal no estresante
B) Inducir el parto
C) Solicitar Doppler maternofetal
D) Realizar amnioinfusión
E) Realizar cesárea

PREGUNTA 17 3.01.1.010

**17.** **Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante
B) Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas
C) Inducir el parto con misoprostol
D) Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones

PREGUNTA 18 3.01.1.010

**18.** **Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:**

A) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
B) Interrumpir por cesárea
C) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria
D) Solicitar estudio de líquido amniótico
E) Indicar reposo y control en 48 horas

## BLOQUE 2 PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

PREGUNTA 19 3.01.2.007

**19.** **Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentas, desde inicios del embarazo, pero que han ido en aumento. Hace 24 horas ha empeorado, al punto que no ha podido ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. El diagnóstico más probable es:**

A) Gastroparesia gestacional
B) Cólico biliar
C) Hepatitis
D) Hiperemesis gravídica
E) Síndrome de HELLP

PREGUNTA 20 3.01.1.011

**20.** **Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?**

A) Losartán
B) Enalapril
C) Nifedipino
D) Espironolactona
E) Doxazosina

PREGUNTA 21 3.01.1.011

**21.** **Una primigesta de 32 semanas de gestación acude a control prenatal. Se constata presión arterial de 145/95 mmHg, repetida a las 4 horas con 148/94 mmHg. Se encuentra asintomática, sin cefalea ni escotomas. La proteinuria de 24 horas informa 450 mg (normal < 300 mg). El recuento de plaquetas es de 210.000/mm³, creatinina 0.7 mg/dL y transaminasas normales. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A) Hipertensión arterial crónica
B) Hipertensión gestacional transitoria
C) Preeclampsia sin criterios de severidad
D) Síndrome HELLP incipiente
E) Eclampsia inminente

PREGUNTA 22 3.01.1.011

**22.** **¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está CONTRAINDICADO DE FORMA ABSOLUTA durante el segundo y tercer trimestre del embarazo debido a su asociación con hipoplasia pulmonar, oligohidramnios y falla renal fetal anúrica irreversible?**

A) Labetalol
B) Alfa-metildopa
C) Enalapril
D) Nifedipino
E) Hidralazina

PREGUNTA 23 3.01.2.003

**23. Embarazada de 36 semanas con presión arterial 170/110 y cefalea frontal intensa que no cede con analgesia. Sin convulsiones. ¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Hospitalizar, labetalol EV para control de PA, sulfato de magnesio profiláctico e interrupción del embarazo
B) Nifedipino oral y control ambulatorio
C) Sulfato de magnesio solo
D) Inducción con oxitocina inmediata sin otro manejo
E) Hidralazina oral y observar

PREGUNTA 24 3.01.2.004

**24. Una paciente de 25 años, primigesta con 32 semanas de gestación, presenta cefalea intensa y malestar general. Al examen Fsico destaca una presión arterial de 170/110 mmHg, por lo que se administra labetalol endovenoso, logrando cifras tensionales de 140/90 mmHg. Sin embargo, dos horas después presenta una convulsión tónico-clónica de 2 minutos de duración. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar lorazepam endovenoso
B) Administrar labetalol endovenoso
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Administrar tocolí2cos endovenosos
E) Realizar maduración pulmonar

PREGUNTA 25 3.01.2.004

**25. Una paciente de 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad se encuentra en tratamiento con infusión continua de Sulfato de Magnesio a 2 g/hora. Al realizar el control clínico horario, el médico constata: paciente somnolienta pero orientada, frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y ausencia completa del reflejo rotuliano bilateral. La diuresis de la última hora fue de 15 mL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata?**

A) Aumentar la infusión de sulfato de magnesio a 3 g/hora para asegurar efecto anticonvulsivante
B) Suspender de inmediato la infusión de Sulfato de Magnesio y administrar Gluconato de Calcio al 10% 1 g por vía endovenosa lenta
C) Administrar un bolo de Diazepam endovenoso
D) Realizar intubación orotraqueal sin administrar antídotos
E) Indicar Furosemida endovenosa para forzar la diuresis

PREGUNTA 26 3.01.2.004

**26. Una embarazada de 32 semanas consulta en urgencia por dolor epigástrico intenso y constante irradiado al hipocondrio derecho y náuseas. PA: 165/105 mmHg. En los exámenes de laboratorio se constata: Hemoglobina 9.2 g/dL, Frotis con abundantes esquistocitos, LDH 880 U/L, Bilirrubina total 2.4 mg/dL a predominio indirecto, GOT/AST 160 U/L, GPT/ALT 145 U/L y recuento de plaquetas de 62.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta obstétrica definitiva?**

A) Hepatitis viral aguda; manejo médico ambulatorio con reposo
B) Colecistitis aguda litiásica; colecistectomía laparoscópica de urgencia
C) Síndrome HELLP; estabilización materna con sulfato de magnesio, antihipertensivos e interrupción del embarazo
D) Púrpura trombocitopénico trombótico; plasmaféresis de urgencia manteniendo el embarazo
E) Hígado graso agudo del embarazo; manejo expectante con corticoides por 7 días

PREGUNTA 27 3.01.2.004

**27. Durante el trabajo de parto de una primigesta de 38 semanas con preeclampsia severa, se registra una presión arterial sostenida de 175/115 mmHg. La paciente refiere cefalea frontal punzante. ¿Cuál es el fármaco de rescate endovenoso de primera línea para el control rápido de la crisis hipertensiva en este contexto?**

A) Nitroprusiato de sodio en infusión continua
B) Labetalol endovenoso en bolos crecientes (20 mg inicial, luego 40 y 80 mg)
C) Enalapril endovenoso a 1.25 mg
D) Furosemida endovenosa en bolo de 40 mg
E) Nifedipino sublingual mordido

PREGUNTA 28 3.01.2.004

**28. ¿Cuál es la causa directa más frecuente de muerte materna en pacientes que sufren una crisis de Eclampsia?**

A) Ruptura uterina masiva
B) Hemorragia intracerebral / Accidente cerebrovascular hemorrágico
C) Insuficiencia renal aguda tubular
D) Shock anafiláctico por sulfato de magnesio
E) Embolia de líquido amniótico

PREGUNTA 29 3.01.1.004

**29. Una mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas, en exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno 108mg/dL. Su examen físico es normal, con altura uterina sobre el pubis. La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
B) Indicar dieta y mantener control habitual
C) Solicitar hemoglobina glicosilada
D) Indicar insulina subcutánea
E) Solicitar nueva glicemia de ayunas

PREGUNTA 30 3.01.1.004

**30. Una primigesta de 26 semanas sin antecedentes mórbidos se realiza la Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 g (PTGO 75g). Los resultados informan: Glicemia basal de 86 mg/dL y Glicemia a las 2 horas de 152 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial correcta?**

A) Examen normal; citar a control prenatal habitual en 4 semanas
B) Intolerancia a la glucosa del embarazo; repetir la prueba a las 32 semanas
C) Diabetes Gestacional; iniciar terapia nutricional fraccionada y automonitoreo glucémico capilar
D) Diabetes Pregestacional; hospitalizar de inmediato para bomba de insulina endovenosa
E) Diabetes Gestacional; iniciar Metformina oral 850 mg cada 12 horas como fármaco de elección

PREGUNTA 31 3.01.1.004

**31. Una paciente con Diabetes Gestacional en tratamiento con dieta estricta desde hace 2 semanas trae su registro de glicemias capilares ambulatorias (4 controles diarios: ayunas y 2 horas post desayuno, almuerzo y cena). De 28 controles realizados en la semana, 8 controles postprandiales se sitúan entre 135 y 150 mg/dL (metas: ayunas < 95 mg/dL, 2 horas < 120 mg/dL). ¿Cuál es la conducta médica indicada?**

A) Mantener solo la dieta y reevaluar en 1 mes
B) Iniciar tratamiento farmacológico con Insulina
C) Indicar ayuno prolongado saltándose la cena
D) Prescribir Glibenclamida oral
E) Interrumpir el embarazo de inmediato por vía cesárea

PREGUNTA 32 3.01.1.004

**32. ¿Cuál de las siguientes complicaciones neonatales se asocia DIRECTAMENTE con la hiperglicemia materna no controlada durante el embarazo mediante el mecanismo de hiperinsulinismo fetal reactivo?**

A) Hiperglicemia neonatal cetósica en las primeras horas de vida
B) Hipoglicemia neonatal sintomática severa en las primeras 2 a 4 horas de vida
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Agenesia renal bilateral congénita
E) Hipercalcemia neonatal idiopática

PREGUNTA 33 3.01.1.004

**33. A una embarazada de 10 semanas se le realiza su primer control prenatal. La glicemia plasmática en ayunas resulta en 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayunas y arroja 106 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico según la normativa perinatal de Chile?**

A) Embarazo normal; el corte de ayunas en el primer trimestre es 110 mg/dL
B) Diabetes Gestacional precoz
C) Diabetes Mellitus pregestacional manifiesta
D) Intolerancia a los carbohidratos que no requiere seguimiento
E) Falso positivo por estrés del primer trimestre

PREGUNTA 34 3.01.1.003

**34. Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A) Transaminasas
B) Ecografía abdominal
C) Ácidos biliares
D) Fosfatasas alcalinas
E) Bilirrubina total y diferenciada

PREGUNTA 35 3.01.1.003

**35. Una embarazada de 33 semanas consulta por prurito intenso en palmas de las manos y plantas de los pies que empeora por las noches desde hace una semana. Al examen físico no presenta erupciones cutáneas, solo lesiones lineales de rascado. Las pruebas hepáticas muestran GOT 85 U/L y GPT 110 U/L con bilirrubina total de 0.9 mg/dL. Los ácidos biliares séricos resultan en 54 umol/L. ¿Cuál es el diagnóstico y el fármaco de elección?**

A) Erupción polimorfa del embarazo; Clobetasol tópico
B) Colestasia intrahepática del embarazo severa; Ácido Ursodesoxicólico oral
C) Hígado graso agudo del embarazo; Hidrocortisona endovenosa
D) Escabiosis del embarazo; Permetrina al 5% tópica
E) Preeclampsia atípica; Sulfato de magnesio en infusión continua

PREGUNTA 36 3.01.1.003

**36. ¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual (Registro Basal No Estresante semanal) NO es suficiente para garantizar la seguridad fetal en pacientes con Colestasia Intrahepática del Embarazo severa?**

A) Porque los ácidos biliares impiden la transmisión de las ondas Doppler
B) Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito e impredecible de arritmia cardíaca fetal aguda o vasoespasmo placentario agudo, sin hipoxia crónica previa
C) Porque todos los fetos con CIE presentan taquicardia basal fija irreversible
D) Porque la colestasia solo afecta a la madre y el feto nunca tiene complicaciones
E) Porque el ácido ursodesoxicólico altera artificialmente el trazado cardiofetal

PREGUNTA 37 3.01.2.013

**37. Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por con- tracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal pre- senta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variante mentoiliaca derecha posterior. EL monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
B) Hacer fórceps
C) Realizar vaccum de la cabeza fetal
D) Realizar amnioinfusión con rotación manual
E) Hacer cesárea de urgencia

PREGUNTA 38 3.01.1.001

**38. Una paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 °C asociada a dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, que inició hace 48 horas. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto, presión arterial 90/60 mmHg y temperatura 38,7 °C. En el examen ginecológico se observa en la especuloscopía sangre y restos ovulares de mal olor en el canal vaginal. Además, se aprecia útero muy doloroso a la palpación y dolor a la palpación hipogástrica por vía abdominal. Se solicita ecograFa transvaginal que muestra contenido uterino irregular de 18 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar histerectomía
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Administrar an2bió2cos endovenosos y realizar curetaje de la cavidad uterina
D) Administrar metotrexato
E) Administrar misoprostol y conducir el trabajo de aborto

PREGUNTA 39 3.01.1.001

**39. Una paciente de 22 años con 8 semanas de amenorrea acude al servicio de urgencia por sangrado genital rojo oscuro escaso y dolor cólico leve en hipogastrio. Al examen ginecológico se constata sangrado escaso por OCE, OCI cerrado y útero acorde a la edad gestacional. La ecografía transvaginal confirma un saco gestacional intrauterino normoinserto con embrión de LCN 14 mm, con latidos cardíacos fetales presentes y rítmicos a 155 lpm. No se visualizan hematomas subcoriales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Aborto incompleto; realizar legrado uterino instrumental de urgencia
B) Amenaza de aborto; indicar reposo relativo, abstinencia sexual y control ambulatorio
C) Aborto retenido; administrar Misoprostol 800 mcg vaginal
D) Embarazo ectópico no roto; administrar Metotrexato intramuscular
E) Aborto inevitable; hospitalizar para infusión de oxitocina

PREGUNTA 40 3.01.1.001

**40. Una mujer de 29 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa a urgencias con fiebre de 38.8°C, taquicardia de 118 lpm, compromiso del estado general y dolor abdominal continuo severo. Refiere haber tenido una pérdida gestacional espontánea hace 4 días de un embarazo de 10 semanas, sin consultar previamente. Al examen físico: abdomen muy sensible en hipogastrio con rebote dudoso. Especuloscopía: cuello dilatado con salida de secreción hemato-purulenta de olor extraordinariamente fétido. El útero está aumentado de tamaño, blando y exquisitamente doloroso al tacto bimanual. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria e imperativa?**

A) Realizar legrado uterino instrumental de inmediato antes de cualquier otra medida
B) Tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro (triple cobertura para anaerobios y Gram negativos) y programar evacuación uterina a las 2-4 horas de cobertura
C) Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico oral y reposo absoluto
D) Administrar Misoprostol 800 mcg por vía oral y alta a domicilio con analgésicos
E) Realizar laparotomía exploradora inmediata para histerectomía total sin intentar antibioticoterapia previa

PREGUNTA 41 3.01.1.001

**41. Una paciente de 25 años acude a la urgencia obstétrica por metrorragia moderada y dolor cólico intenso. En el tacto vaginal se constata cuello uterino con orificio cervical interno abierto y permeable a 2 cm, palpándose tejido ovular en el canal endocervical. La ecografía transvaginal muestra una masa heterogénea intrauterina de 28 mm sugerente de restos embrionarios y trofoblásticos. La paciente se encuentra afebril y con signos vitales normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más exacto?**

A) Amenaza de aborto
B) Aborto retenido
C) Aborto incompleto
D) Aborto completo
E) Embarazo molar parcial

PREGUNTA 42 3.01.1.001

**42. En relación con la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile en tres causales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la causal de violación (Tercera Causal)?**

A) Requiere obligatoriamente que exista una denuncia judicial previa y condena al agresor antes del procedimiento
B) El plazo máximo para su realización es de hasta 12 semanas de gestación en mayores de 14 años, y de hasta 14 semanas en niñas menores de 14 años
C) Cualquier médico objetor de conciencia puede negarse a derivar a la paciente a un centro no objetor
D) No existe límite de edad gestacional para la interrupción en caso de violación comprobada
E) Requiere siempre la aprobación unánime de un comité de ética hospitalario

PREGUNTA 43 3.01.2.001

**43. [URGENCIA: Aborto provocado · 3.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aborto provocado. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 44 3.01.2.010

**44. Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un útero con tono aumentado y tres contracciones uterinas en 10 minutos. La especuloscopía muestra sangre roja oscura en can8dad moderada, sin dilatación cervical. Los la8dos cardiofetales se auscultan a 130 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cesárea de urgencia

B) Realizar maduración pulmonar y conducta expectante

C) Inducir el trabajo de parto con misoprostol

D) Solicitar Doppler fetal

E) Administrar tocolí2cos endovenosos

PREGUNTA 45 3.01.1.002

**45. Embarazada de 20 semanas con hemoglobina de 9.0 g/dL, VCM 72 fL (microcítica), ferritina 8 ng/mL. Sin síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Hierro oral elemental 200 mg/día

B) Transfusión de glóbulos rojos

C) Hierro endovenoso

D) Vitamina B12 intramuscular

E) Ácido fólico

PREGUNTA 46 3.01.1.002

**46. Una paciente de 31 años, con amenorrea de 6 semanas y test de embarazo casero positivo, acude a urgencias por dolor en hemiabdomen inferior izquierdo y sangrado vaginal escaso intermitente en borra de café. Al examen: PA 122/78 mmHg, FC 74 lpm, abdomen sensible en fosa ilíaca izquierda sin defensa ni rebote. La ecografía transvaginal muestra cavidad uterina vacía con línea endometrial de 10 mm y en el anexo izquierdo se aprecia una imagen redondeada hipoecogénica de 2.6 cm de diámetro rodeada por un halo hiperecogénico, sin actividad cardíaca embrionaria ni líquido libre pelviano. El resultado de la β-hCG cuantitativa sérica es de 3.200 UI/L. Las pruebas hepáticas, hematocrito y creatinina son normales. ¿Cuál es la mejor alternativa terapéutica para esta paciente?**

A) Laparotomía de urgencia para histerectomía total y salpingectomía izquierda

B) Administración de Metotrexato intramuscular a dosis única (50 mg/m²)

C) Manejo expectante sin fármacos y control con β-hCG en 1 mes

D) Aspiración manual endouterina (AMEU) de la cavidad endometrial

E) Tratamiento con progesterona micronizada oral 200 mg al día

PREGUNTA 47 3.01.1.002

**47. Una paciente de 26 años, con retraso menstrual de 7 semanas, es traída al servicio de urgencia en ambulancia por dolor abdominal súbito de extrema intensidad en fosa ilíaca derecha y síncope en su domicilio. Al ingreso: somnolienta, muy pálida y sudorosa. Presión arterial de 75/40 mmHg, pulso de 135 lpm filiforme y saturación de 93% ambiental. El abdomen está rígido, doloroso en forma generalizada con marcado signo de Blumberg. Al tacto vaginal se palpa gran dolor en fondo de saco posterior. El test rápido de orina es positivo para gonadotrofina coriónica. ¿Cuál es la conducta inmediata que salva la vida de la paciente?**

A) Indicar Metotrexato intramuscular a dosis de 50 mg/m² y solicitar ecografía transvaginal diferida

B) Reanimación activa con cristaloides endovenosos, activación de protocolo de hemotransfusión y traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora urgente

C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para localizar la fuente de sangrado

D) Instalar sonda Foley, tomar β-hCG sérica cuantitativa y esperar resultado en 3 horas

E) Realizar legrado uterino bajo anestesia local en sala de procedimientos

PREGUNTA 48 3.01.1.002

**48. Una paciente tratada con Metotrexato intramuscular por un embarazo ectópico tubárico acude al policlínico para su seguimiento. Su β-hCG basal (Día 1) fue de 2.400 UI/L. Al Día 4 la β-hCG subió a 2.650 UI/L, y al Día 7 el valor de β-hCG es de 2.100 UI/L. La paciente se encuentra estable y prácticamente sin molestias. ¿Cómo se interpreta esta evolución y cuál es la conducta correcta?**

A) El tratamiento ha fracasado porque el Día 4 aumentó la β-hCG; debe intervenirse quirúrgicamente de inmediato

B) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue superior al 15%, por lo que el tratamiento es exitoso; corresponde continuar con controles semanales de β-hCG

C) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue menor al 15%; está indicada una segunda dosis de Metotrexato o tratamiento quirúrgico

D) La paciente está curada definitivamente y debe recibir el alta sin nuevos exámenes

E) Debe indicarse leucovorina para revertir la toxicidad del metotrexato

PREGUNTA 49 3.01.1.002

**49. ¿Cuál de las siguientes localizaciones anatómicas del embarazo ectópico se asocia clásicamente a una rotura más tardía (entre las 12 y 16 semanas de gestación), pero que al romperse provoca un hemoperitoneo fulminante y cataclísmico por la proximidad y compromiso de la arteria uterina?**

A) Porción ampular de la trompa

B) Porción ístmica de la trompa

C) Porción intersticial o cornual de la trompa

D) Porción fímbrica de la trompa

E) Embarazo cervical

PREGUNTA 50 3.01.2.005

**50. Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda complicada

B) Quiste ovárico torcido

C) Embarazo ectópico roto

D) Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico

E) Rotura folicular hemorrágica

PREGUNTA 51 3.01.1.003

**51. Una paciente de 20 años cursando un embarazo de 12 semanas por amenorrea consulta por metrorragia indolora y vómitos incoercibles. Al examen físico se palpa un útero correspondiente a 18 semanas de gestación. La ecografía transvaginal muestra una masa intrauterina con múltiples cavidades quísticas pequeñas ('patrón en panal de abejas') y ausencia de embrión. La subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana sérica cuantitativa es de 160.000 UI/L. ¿Cuál es el tratamiento primario indicado?**

A) Histerectomía total abdominal de urgencia con salpingooforectomía bilateral

B) Evacuación uterina mediante Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío, con estudio histopatológico

C) Inducción médica con altas dosis de misoprostol oral como único tratamiento

D) Inicio inmediato de poliquimioterapia con esquema EMA-CO antes de cualquier cirugía

E) Punción transabdominal y aspiración de los quistes ováricos tecaluteínicos

PREGUNTA 52 3.01.1.003

**52. Una paciente de 24 años fue sometida a una aspiración de mola hidatiforme completa sin incidentes hace 4 semanas. Se encuentra asintomática. En su control postoperatorio se revisan los valores de β-hCG sérica cuantitativa tomados semanalmente: Semana 1 post-evacuación: 12.000 UI/L; Semana 2: 3.500 UI/L; Semana 3: 3.600 UI/L; Semana 4: 3.800 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médica indicada?**

A) Evolución post-evacuación completamente normal; continuar controles habituales sin cambios

B) Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG); etapificar con score FIGO y derivar a ginecología oncológica para quimioterapia

C) Nuevo embarazo intrauterino en evolución; solicitar ecografía transvaginal y dar de alta de patología trofoblástica

D) Infección puerperal tardía; iniciar antibioticoterapia con amoxicilina más ácido clavulánico

E) Realizar un nuevo legrado uterino cortante enérgico para limpiar la cavidad

PREGUNTA 53 3.01.1.019

**53. Una embarazada de 16 semanas acude a control prenatal asintomática. El urocultivo de rutina del primer trimestre informa: recuento de colonias de Escherichia coli de 150.000 UFC/mL, sensible a cefadroxilo, nitrofurantoína y ampicilina. ¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A) No tratar, dado que la bacteriuria asintomática no se trata en mujeres jóvenes

B) Indicar Cefadroxilo oral por 7 días y solicitar urocultivo de control a los 7-14 días de finalizado el tratamiento

C) Hospitalizar de inmediato para tratamiento con Ceftriaxona endovenosa

D) Indicar consumo abundante de jugo de arándanos sin antibióticos

E) Repetir el urocultivo a las 28 semanas sin iniciar fármacos

PREGUNTA 54 3.01.1.019

**54.** **Una primigesta de 28 semanas consulta en Urgencia por fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, vómitos y dolor en fosa lumbar derecha de 24 horas de evolución. Al examen: T° 39.0°C, PA 105/65 mmHg, FC 112 lpm. Puñopercusión lumbar derecha francamente positiva. En el monitor cardiofetal se detectan contracciones uterinas aisladas y FCF de 160 lpm. ¿Cuál es el lugar y el tratamiento de elección inicial?**

A) Manejo ambulatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días
B) Hospitalización inmediata en sala de obstetricia para Ceftriaxona o Cefazolina endovenosa, hidratación y monitoreo materno-fetal
C) Manejo ambulatorio con Ciprofloxacino oral por 10 días
D) Cesárea de urgencia por riesgo inminente de sepsis
E) Indicar paracetamol oral y derivar a policlínico de urología

## BLOQUE 4 METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

PREGUNTA 55 3.01.1.004

**55.** **Una multigesta de 33 semanas con antecedente de dos cesáreas anteriores acude al servicio de urgencias por sangrado vaginal rojo rutilante abundante de inicio súbito hace 2 horas, sin dolor abdominal ni contracciones. Al examen: PA 118/72 mmHg, FC 78 lpm. Abdomen blando, depresible, útero relajado e indoloro. El monitoreo cardiofetal basal muestra FCF de 145 lpm con variabilidad normal y movimientos fetales presentes. ¿Cuál de las siguientes acciones está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en este momento?**

A) Realizar una ecografía transvaginal
B) Efectuar un tacto vaginal digital
C) Instalar una vía venosa periférica con teflón grueso
D) Colocar un espéculo estéril para verificar el origen del sangrado
E) Tomar exámenes de hemograma, grupo sanguíneo y pruebas de coagulación

PREGUNTA 56 3.01.1.004

**56.** **Una primigesta de 35 semanas con antecedente de Preeclampsia sin criterios de severidad en control acude a urgencias por dolor abdominal intenso, continuo y repentino en hipogastrio de 1 hora de evolución. Al examen físico: PA 155/95 mmHg, FC 100 lpm. El útero se palpa intensamente contracturado, duro como madera, no relajándose entre las contracciones y siendo muy doloroso a la palpación. A la especuloscopía se observa sangrado genital oscuro con coágulos en cuantía moderada. En el monitor fetal se evidencia una frecuencia cardíaca fetal basal de 100 lpm con variabilidad mínima y desaceleraciones tardías profundas (DIP II). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata a seguir?**

A) Placenta previa oclusiva total; indicar reposo absoluto y tocolíticos con sulfato de magnesio
B) Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI); proceder a cesárea de urgencia inmediata
C) Rotura de vasa previa; realizar punción de membranas para acelerar el parto
D) Amenaza de parto prematuro; administrar nifedipino oral y enviar a domicilio
E) Cólico renal complicado; analgesia con AINEs endovenosos y ecografía renal

PREGUNTA 57 3.01.1.004

**57.** **Una paciente en trabajo de parto activo de término con antecedente de cesárea previa hace 2 años recibe infusión de oxitocina para conducción. Súbitamente refiere un dolor abdominal lancinante y lacerante intensísimo en hipogastrio, tras lo cual manifiesta alivio transitorio del dolor y cese completo de las contracciones uterinas. Al examen: la paciente se torna pálida y diaforética, con PA 80/50 mmHg y FC 125 lpm. Al tacto vaginal se constata que la cabeza fetal que se encontraba en espinas +1 ha ascendido y ya no es palpable en la pelvis, palpándose partes fetales con extraordinaria facilidad bajo la pared abdominal anterior. El registro fetal muestra bradicardia severa a 60 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Placenta previa sangrante
B) Embolia de líquido amniótico
C) Rotura uterina completa
D) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
E) Inversión uterina puerperal

PREGUNTA 58 3.01.1.004

**58.** **Durante la atención de un parto de término, inmediatamente tras realizar la rotura artificial de membranas (amniotomía), se observa la salida de líquido amniótico teñido con sangre fresca rutilante en cuantía moderada. En el monitor cardiofetal se aprecia de forma simultánea una brusca caída de la frecuencia cardíaca fetal a 70 lpm con patrón sinusoidal y desaceleraciones severas sostenidas. La madre se mantiene normotensa, afebril, sin dolor abdominal y con dinámica uterina fisiológica de parto normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rotura de Vasa Previa
B) Placenta previa oclusiva total
C) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
D) Laceración de cuello uterino
E) Corioamnionitis clínica aguda

PREGUNTA 59 3.01.2.011

**59. Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros al orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar tocolíticos
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Administrar corticoides para maduración pulmonar
D) Repetir la ecografía a las 37 semanas
E) Realizar cesárea

PREGUNTA 60 3.01.2.015

**60. Puérpera con una cesárea anterior presenta trabajo de parto espontáneo. A las 2 horas de trabajo de parto activo, refiere dolor uterino súbito diferente a las contracciones, y el MEFI muestra bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la conducta inmediata?**

A) Fórceps de urgencia
B) Conducción con oxitocina
C) Vacuum
D) Cesárea de urgencia inmediata
E) Espera activa y analgesia

PREGUNTA 61 3.01.1.005

**61. Mujer con reglas irregulares, test de embarazo +, fur no confiable pero si segura, amenorrea de 10 semanas. Como saber edad gestacional:**

A) longitud cefalo- caudal
B) longitud saco gestacional
C) niveles bcg
D) FUR segura
E) Interrupción del embarazo

PREGUNTA 62 3.01.1.005

**62. Una gestante de 31 semanas consulta por pérdida de líquido claro por vagina hace 6 horas. La especuloscopía estéril confirma salida de líquido amniótico por el orificio cervical externo. Signos vitales: T° 36.8°C, PA 110/70 mmHg, FC 76 lpm. El feto presenta una FCF de 145 lpm con variabilidad conservada y no hay dinámica uterina ni dolor a la palpación del fondo uterino. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada a seguir?**

A) Realizar tacto vaginal para evaluar dilatación cervical e inducir el parto de inmediato con oxitocina
B) Hospitalizar en ARO, administrar Betametasona intramuscular (2 dosis) y esquema de antibióticos de latencia (Ampicilina + Eritromicina)
C) Manejo ambulatorio con reposo en cama y control ecográfico en 2 semanas
D) Programar cesárea de urgencia en las próximas 2 horas por riesgo de compresión de cordón
E) Iniciar tocolisis continua con nifedipino oral durante 14 días

PREGUNTA 63 3.01.1.005

**63. Una primigesta de 30 semanas hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador presenta súbitamente fiebre de 38.6°C, calofríos y taquicardia materna de 115 lpm. Al examen obstétrico: el útero está hipertónico, tenso y muy sensible al menor contacto. A la especuloscopía fluye líquido amniótico francamente purulento con olor putrefacto. El monitor fetal muestra taquicardia fetal sostenida a 175 lpm con variabilidad mínima. El hemograma confirma leucocitosis de 19.500 /mm³ con 12% de baciliformes. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e impostergable?**

A) Administrar antipiréticos y tocolíticos para frenar las contracciones y esperar a las 34 semanas
B) Iniciar antibioticoterapia endovenosa con Ampicilina más Gentamicina y proceder a la interrupción INMEDIATA del embarazo
C) Administrar un segundo ciclo de betametasona y esperar 48 horas para asegurar la maduración pulmonar
D) Realizar una amniocentesis diagnóstica para cultivo y esperar el resultado en 72 horas
E) Indicar infusión de sulfato de magnesio y mantener conducta expectante

PREGUNTA 64 3.01.1.005

**64. Una gestante de 36 semanas consulta por pérdida abundante de líquido claro por genitales hace 8 horas. Al examen con espéculo estéril se observa cuello borrado en un 50% con 2 cm de dilatación y abundante salida de líquido amniótico claro por el orificio cervical. La paciente se encuentra afebril, con signos vitales normales y monitoreo fetal reactivo sin contracciones uterinas dolorosas regulares. ¿Cuál es la conducta indicada según las guías clínicas del MINSAL?**

A) Inducir el parto de inmediato con oxitocina o prostaglandinas
B) Administrar betametasona intramuscular y mantener reposo por 1 semana
C) Indicar antibióticos de latencia por 7 días y dar el alta domiciliaria
D) Indicar tocolisis con nifedipino oral para evitar el parto prematuro
E) Programar cesárea electiva para la semana 39

PREGUNTA 65 3.01.1.005

**65. ¿Cuál de las siguientes maniobras o exámenes está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como método diagnóstico inicial en una paciente con sospecha de rotura prematura de membranas que no se encuentra en trabajo de parto activo?**

A) Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva
B) Tacto vaginal digital
C) Test de cristalización en hoja de helecho
D) Determinación de pH con papel de nitrazina
E) Detección de alfa-microglobulina-1 placentaria (PAMG-1)

PREGUNTA 66 3.01.2.012

**66. Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constatan contracciones de 3 en 10 minutos, cuello uterino borrado 50%, dilatación 1 cm. FCF 130 lpm con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial?**

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

PREGUNTA 67 3.01.2.014

**67. Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en cefálica, sin signos de sufrimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar, maduración pulmonar con corticoides, antibióticos y vigilancia
B) Inducción del parto inmediata
C) Cesárea de urgencia
D) Alta con control ambulatorio
E) Amnioinfusión

PREGUNTA 68 3.01.1.006

**68. Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, sin alteraciones en su examen ginecológico. Se solicitan niveles plasmáticos de HCG, que resultan 4.000 UI/L y se realiza ecografía transvaginal que muestra una masa anexial derecha de 3 cm de diámetro, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir los niveles de HCG en 48 horas
B) Realizar salpingotomía por laparotomía
C) Realizar salpingectomía por vía laparoscópica
D) Indicar metotrexato por vía intramuscular
E) Controlar con una ecografía en 10 días

PREGUNTA 69 3.01.1.006

**69. Una primigesta de 30 semanas acude a la urgencia obstétrica por contracciones uterinas dolorosas cada 5 minutos de 2 horas de evolución. Al examen: T° 36.7°C, PA 112/68 mmHg, FC 76 lpm. En la ecografía transvaginal se mide una longitud cervical de 16 mm con embudización del OCI y dilatación de 2 cm. El registro cardiofetal basal es de 140 lpm reactivo. ¿Cuál es la conducta médica integral de primera línea para esta paciente?**

A) Indicar reposo en domicilio y consumo abundante de líquidos orales
B) Hospitalizar en ARO, iniciar Nifedipino oral, administrar Betametasona intramuscular (12 mg cada 24 horas por 2 dosis) e infusión de Sulfato de Magnesio para neuroprotección fetal
C) Realizar cesárea de urgencia inmediata por riesgo inminente de parto en menos de 1 hora
D) Administrar Indometacina rectal durante 14 días y dar el alta hospitalaria
E) Realizar cerclaje cervical de emergencia de forma inmediata

PREGUNTA 70 3.01.1.006

**70. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO el uso de fármacos tocolíticos para frenar las contracciones uterinas?**

A) Embarazada de 28 semanas con contracciones uterinas dolorosas, cérvix de 20 mm y feto reactivo
B) Gestante de 31 semanas con dinámica uterina y antecedente de un parto prematuro anterior
C) Gestante de 29 semanas con sospecha clínica de Corioamnionitis (fiebre materna de 38.8°C, dolor uterino intenso y taquicardia fetal)
D) Embarazada de 33 semanas con embarazo gemelar bicorial y cuello borrado en un 50%
E) Embarazada de 30 semanas con infección urinaria baja en tratamiento con cefadroxilo y dinámica uterina

PREGUNTA 71 3.01.1.007

**71. Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra en buenas condiciones generales, sin síntomas. Al examen tiene signos vitales normales y su ecografía obstétrica muestra al primer gemelo creciendo con una estimación de peso fetal de 2.850 gramos y al segundo gemelo con una estimación de 2.750 gramos, con líquido amniótico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar control ecográfico en una semana
B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C) Inducir el parto de inmediato
D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E) Realizar cesárea de urgencia

PREGUNTA 72 3.01.2.021

**72. Una paciente de 30 años, mul`para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con es8mación de peso fetal de 3.800 gramos. Ingresa en trabajo de parto en fase latente, recibiendo anestesia peridural a los 4 cm de dilatación. Ha permanecido con 6 cm de dilatación en las úl8mas 3 horas y se palpa cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en variante occípito-ilíaca izquierda posterior. Presenta cuatro contracciones uterinas de 50 segundos de duración cada 10 minutos. ¿Cuál es la causa de la demora en el avance de su trabajo de parto?**

A) Dinámica uterina insuficiente
B) Distocia de posición
C) Desproporción céfalo-pélvica
D) Macrosomía fetal
E) Distocia de presentación

PREGUNTA 73 3.01.1.008

**73.** **Una paciente de 25 años acude al servicio de urgencia por metrorragia abundante de 2 días de evolución. Tiene antecedente de atraso menstrual de 4 semanas, dudoso debido a reglas irregulares que ocurren cada 30 a 45 días. Al examen Fsico se realiza especuloscopía con visualización de sangre que sale del orificio cervical externo, y la palpación uterina muestra un útero aumentado de tamaño como para un embarazo de 12 semanas. Se solicita subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, que resulta 200.000 U/L, y se realiza ecograFa transvaginal que muestra imagen en "tormenta de nieve". ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Aborto en evolución
B) Embarazo roto
C) Mola hida2diforme
D) Metrorragia disfuncional
E) Tumor del si2o de inserción placentaria

PREGUNTA 74 3.01.1.008

**74.** **Durante la atención de un parto vaginal de una paciente con feto macrosómico, se produce la salida de la cabeza fetal, la cual inmediatamente se retrae con fuerza contra el periné ('signo de la tortuga'). A pesar de una tracción axial suave, el hombro anterior queda impactado detrás de la sínfisis púbica impidiendo la salida del tórax. ¿Cuáles son las dos maniobras de primera línea recomendadas para resolver esta emergencia obstétrica?**

A) Maniobra de Kristeller enérgica sobre el fondo uterino y tracción cefálica forzada
B) Maniobra de McRoberts (hiperflexión de muslos maternos sobre el abdomen) combinada con presión suprapúbica (Mazzanti)
C) Realización inmediata de cesárea con feto desprendido (maniobra de Zavanelli) sin intentar maniobras externas
D) Fractura intencional de ambas clavículas fetales como maniobra primaria de elección
E) Sinfisiotomía quirúrgica inmediata bajo anestesia general

PREGUNTA 75 3.01.1.008

**75.** **Durante la fase activa de un trabajo de parto a término, el trazado del monitoreo cardiofetal continuo muestra desaceleraciones periódicas de la frecuencia cardíaca fetal que comienzan de forma simultánea con el inicio de la contracción uterina, alcanzando su nadir exactamente en el punto de máxima presión de la contracción ('en imagen en espejo') y retornando a la línea de base de 135 lpm una vez que finaliza la contracción. La variabilidad se mantiene moderada en 15 lpm y el tono uterino es normal. ¿Cuál es el significado fisiopatológico de este hallazgo y la conducta a seguir?**

A) Indica acidosis fetal severa por desprendimiento prematuro de placenta; realizar cesárea inmediata
B) Corresponde a desaceleraciones precoces (DIP I) por compresión de la cabeza fetal; son fisiológicas y no requieren intervención quirúrgica
C) Indica hipoxia fetal progresiva por insuficiencia útero-placentaria; administrar tocolíticos y suspender el parto
D) Corresponde a compresión crítica del cordón umbilical con prolapso oculto; trasladar a pabellón en decúbito prono
E) Indica anemia fetal aguda grave; solicitar sangre para transfusión intrauterina inmediata

PREGUNTA 76 3.01.1.008

**76.** **Una multípara en trabajo de parto activo a 7 cm de dilatación presenta en el registro cardiofetal intraparto desaceleraciones repetidas cuya caída de la frecuencia cardíaca comienza después del acmé de la contracción uterina, alcanzando el nadir a los 30 segundos tras la contracción y retornando lentamente a la línea de base. Se constata además una línea de base en 155 lpm con variabilidad ausente (< 3 lpm). ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada?**

A) Observación expectante durante 4 horas para evaluar el descenso espontáneo
B) Aumentar la dosis de oxitocina endovenosa para acelerar el expulsivo
C) Iniciar medidas de reanimación intrauterina y proceder de inmediato a la interrupción del embarazo mediante cesárea de urgencia
D) Administrar antibióticos orales y solicitar urocultivo
E) Indicar anestesia peridural para mejorar la relajación del piso pelviano

PREGUNTA 77 3.01.1.008

**77.** **¿Cuál es la complicación neurológica neonatal clásica más frecuente derivada de la aplicación de una tracción lateral excesiva y violenta sobre la cabeza fetal durante el desprendimiento en un parto complicado por distocia de hombros?**

A) Parálisis de Bell del nervio facial
B) Parálisis braquial superior de Erb-Duchenne (raíces C5-C6)
C) Parálisis braquial inferior de Klumpke (raíces C8-T1)
D) Parálisis del nervio ciático poplíteo externo
E) Parálisis frénica bilateral con luxación atloidoaxoidea

PREGUNTA 78 3.01.1.008

**78.** **Una mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, que es manejado con legrado, con buen resultado y sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como "mola hidatiforme". La conducta más adecuada es:**

A) Indicar anticonceptivos orales por 12 meses
B) Controlar con beta-HCG seriada
C) Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas
D) Quimioterapia profiláctica
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 79 3.01.1.008

**79.** **Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como "mola completa". Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Seguirla con niveles seriados de HCG
B) Realizar biopsia endometrial
C) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
D) Repetir el legrado
E) Indicar metotrexato

PREGUNTA 80 3.01.1.009

**80. Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:**

A) cesarea inmediata
B) programar cesarea 39 semanas
C) esperar inicio tdp
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 81 3.01.1.009

**81. Una paciente de 28 años con antecedente de Preeclampsia con criterios de severidad en tratamiento con labetalol presenta una hemorragia postparto masiva de 1.200 mL tras un parto vaginal. Al examen físico se palpa un útero atónico, supraumbilical y blando. Se inicia masaje bimanual y oxitocina endovenosa continua. El médico de turno solicita un segundo uterotónico para frenar el sangrado. ¿Cuál de los siguientes fármacos uterotónicos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en esta paciente?**

A) Misoprostol sublingual
B) Metilergonovina intramuscular
C) Ácido Tranexámico endovenoso
D) Carbetocina endovenosa
E) Balón hidrostático de Bakri

PREGUNTA 82 3.01.1.009

**82. Una puérpera inmediata de parto vaginal presenta sangrado genital rojo rutilante activo continuo y abundante. A la palpación abdominal el fondo uterino se palpa firme, contraído como una pelota ('globo de seguridad de Pinard') a nivel infraumbilical. Se revisó la placenta y se constató completa con todas sus membranas. ¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia y cuál es la conducta médica indicada?**

A) Atonía uterina oculta; administrar de inmediato una segunda dosis de oxitocina y metilergonovina
B) Trauma del canal del parto (desgarro cervical o vaginal); colocar valvas ginecológicas, explorar minuciosamente el canal y suturar las lesiones sangrantes
C) Retención de cotiledón aberrante; realizar legrado uterino instrumental de urgencia a ciegas
D) Coagulación intravascular diseminada; infundir 4 unidades de plasma fresco congelado
E) Inversión uterina puerperal; intentar reposición manual inmediata de Johnson

PREGUNTA 83 3.01.1.009

**83. En una paciente con hemorragia postparto inmediata por atonía uterina que no ha respondido al masaje uterino bimanual vigoroso ni a la administración combinada escalonada de oxitocina, ácido tranexámico y misoprostol, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico conservador antes de decidir una laparotomía exploradora quirúrgica?**

A) Realizar legrado cortante enérgico con cureta metálica
B) Instalación de un balón intrauterino de taponamiento hidrostático (Balón de Bakri)
C) Histerectomía obstétrica total de emergencia como primer recurso
D) Administración de heparina sódica en infusión continua
E) Mantener conducta expectante con reposo en cama y bolsa de arena sobre el abdomen

PREGUNTA 84 3.01.1.009

**84. Durante el alumbramiento de un parto vaginal, el profesional a cargo tracciona con fuerza el cordón umbilical en momentos en que el útero no presentaba contracción. De forma instantánea la paciente presenta dolor abdominal agudo severo, palidez extrema, bradicardia marcada a 45 lpm y shock profundo con presión arterial de 60/30 mmHg. A la palpación abdominal el útero no se palpa en el abdomen y en la especuloscopía se aprecia una gran masa globular rojo-violácea que asoma por el introito vaginal con la placenta aún adherida. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta catástrofe y cuál es la conducta médica inmediata?**

A) Placenta previa sangrante; cesárea urgente
B) Inversión Uterina Puerperal en shock neurogénico; suspender uterotónicos, relajar el miometrio y realizar la reposición manual inmediata del fondo uterino (Maniobra de Johnson)
C) Rotura uterina completa; infundir oxitocina a dosis máximas
D) Embolia de líquido amniótico; desfibrilación ventricular inmediata
E) Prolapso de cúpula vaginal; analgesia ambulatoria y derivación diferida

PREGUNTA 85 3.01.1.010

**85. Una puérpera de 4 días de una cesárea de urgencia presenta fiebre de 38.9°C, calofríos y dolor abdominal en hipogastrio. Al examen físico se constata útero blando palpable a 3 cm sobre el ombligo, muy doloroso al tacto, con salida de loquios achocolatados con olor putrefacto. La herida quirúrgica se encuentra sana y sin eritema. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico de primera línea indicado?**

A) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas en forma ambulatoria por 7 días
B) Hospitalización para tratamiento endovenoso con Clindamicina más Gentamicina
C) Ciprofloxacino oral más Metronidazol oral en domicilio
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única ambulatoria
E) Vancomicina endovenosa más Imipenem en dosis de choque

PREGUNTA 86 3.01.1.010

**86. Una primípara de 3 semanas de puerperio en lactancia materna exclusiva acude a la urgencia por presentar fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, mialgias y dolor severo en la mama derecha de 24 horas de evolución. Al examen físico se aprecia en el cuadrante superoexterno de la mama derecha una placa eritematosa de 6 cm, caliente, indurada y muy dolorosa a la palpación, sin fluctuación. La mama izquierda y ambas axilas son normales. Se observan pequeñas grietas en ambos pezones. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?**

A) Suspender definitivamente la lactancia materna e indicar Ciprofloxacino oral por 7 días
B) Prescribir Cloxacilina o Cefadroxilo oral por 10 a 14 días y RECOMENDAR CONTINUAR con el amamantamiento en ambas mamas
C) Realizar drenaje quirúrgico inmediato con anestesia general en pabellón
D) Indicar solo compresas frías y paracetamol sin antibióticos
E) Suspender la lactancia en la mama derecha e inhibir la prolactina con cabergolina

PREGUNTA 87 3.01.2.006

**87.** **Una paciente de 37 años, puérpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, asociada a fiebre hasta 38,5 grados Celsius y dolor abdominal bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Inercia uterina
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Endometritis
D) Restos ovulares
E) Miometritis

PREGUNTA 88 3.01.2.009

**88.** **Una paciente de 34 años, puérpera hace 15 días, dando lactancia materna, presenta dolor en la mama derecha, de 3 días de evolución, que ha aumentado y se ha acompañado de eritema y malestar general. Al examen físico tiene FC: 78x', PA: 120/82 mmHg, Tº: 38,0ºC y se observa mama derecha dolor a la palpación de los cuadrantes superiores, los que se palpan indurados y con aumento de la temperatura local, asociado a eritema de la piel de dicha zona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar drenaje mamario quirúrgico
B) Suspender la lactancia materna
C) Iniciar antibióticos
D) Indicar analgésicos
E) Aplicar frío local y luego calor local, alternadamente

PREGUNTA 89 3.01.1.012

**89.** **Una primigesta de 28 semanas de gestación, sana, con grupo sanguíneo O Rh negativo acude a su control de rutina. Su Test de Coombs Indirecto solicitado a las 28 semanas resulta NEGATIVO. Su esposo es Rh positivo conocido. ¿Cuál es la conducta médica indicada según las guías clínicas del MINSAL?**

A) Indicar interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea electiva
B) Administrar Inmunoglobulina Anti-D (Rhogam) 300 mcg intramuscular profiláctica
C) No administrar ninguna vacuna ni fármaco hasta después del parto
D) Realizar amniocentesis diagnóstica para espectrofotometría de líquido amniótico
E) Indicar transfusión de plasma fresco congelado a la madre

PREGUNTA 90 3.01.1.012

**90.** **Una multigesta de 16 semanas acude a control prenatal. Se constata grupo sanguíneo B Rh negativo con Test de Coombs Indirecto POSITIVO con títulos de 1:64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al manejo de esta paciente?**

A) Debe administrarse Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg de inmediato para revertir los títulos de anticuerpos
B) Está contraindicada la administración de Inmunoglobulina Anti-D; debe evaluarse la presencia de anemia fetal mediante Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media
C) Debe realizarse de inmediato una exanguinotransfusión total materna
D) Se debe indicar legrado uterino terapéutico por inviabilidad fetal inminente
E) Los anticuerpos de tipo IgM no cruzan la placenta, por lo que el feto no corre ningún peligro

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

VIH en ginecobstetricia

3.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La triterapia se inicia a las 20 semanas y es la medida más importante, ya que baja la carga viral, que es el predictor de trasmisibilidad.

### PREGUNTA 2 Respuesta: B

**Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre**

3.01.2.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sufrimiento fetal y prueba de parto fracasada: La paciente presenta signos de sufrimiento fetal, incluyendo desaceleraciones tardías en el registro fetal y líquido amniótico meconial. Si bien sería aceptable comenzar con la reanimación intrauterina, en este caso, además, se observa una prueba de parto fracasada, por lo que se debe indica cesárea de inmediato.

### PREGUNTA 3 Respuesta: B

**Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre**

3.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La dosis de 0.4 mg/día es para mujeres de bajo riesgo sin antecedentes de DTN; además, iniciarlo tras la falta menstrual puede ser tardío (el tubo neural se cierra al día 28 post-concepción). B) Correcta. En mujeres con antecedente de un hijo previo con defecto del tubo neural (anencefalia, espina bífida, mielomeningocele), la dosis profiláctica debe incrementarse 10 veces, prescribiendo 4.0 a 5.0 mg/día de ácido fólico por vía oral, iniciado idealmente al menos 1 a 3 meses antes de la fecundación y mantenido de forma estricta durante todo el primer trimestre (hasta la semana 12), reduciendo la tasa de recurrencia en más de un 70%. C) Incorrecta. En el 2.° y 3.er trimestre el tubo neural ya está cerrado. D) Incorrecta. La vía es oral diaria. E) Incorrecta. La fortificación de harinas no aporta la dosis requerida para alto riesgo.

### PREGUNTA 4 Respuesta: C

**Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre**

3.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El tratamiento antibiótico oral previo al parto es ineficaz porque el germen recoloniza la vagina y el recto en pocos días desde el reservorio gastrointestinal. B) Incorrecta. La colonización por EGB no es indicación de cesárea. C) Correcta. La colonización vaginorrectal asintomática por Streptococcus agalactiae no se trata antes del parto. La conducta normada internacionalmente y por el MINSAL es consignar la condición de 'Cultivo EGB positivo' e indicar que al ingresar en trabajo de parto activo o con rotura de membranas recibirá Profilaxis Antibiótica Intraparto con Penicilina G sódica EV (dosis de carga de 5 millones de UI seguida de 2.5 a 3 millones cada 4 horas hasta el parto) para prevenir la transmisión vertical y sepsis neonatal precoz. D) Incorrecta. El metronidazol no tiene actividad contra Streptococcus. E) Incorrecta. No se repite el cultivo; una vez positivo, se asume colonizada para el parto.

### PREGUNTA 5 Respuesta: B

**Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)**

3.01.4.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. El reposo en cama no previene la preeclampsia y aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. B) Correcta. El ensayo clínico internacional ASPRE y las guías del MINSAL y de la FIGO establecen que en pacientes identificadas con alto riesgo de preeclampsia mediante Doppler de arterias uterinas alterado (> P95) en el primer trimestre, la administración de Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 100 a 150 mg al día por las noches, iniciada antes de las 16 semanas de gestación y mantenida hasta las 36 semanas, reduce en más del 60 al 70% la incidencia de preeclampsia pretérmino y restricción de crecimiento fetal asociada. C) Incorrecta. La heparina solo se indica en síndrome antifosfolípido o trombofilias específicas. D) Incorrecta. La restricción de sodio y los diuréticos están contraindicados en el embarazo por depleción de volumen plasmático. E) Incorrecta. Los antihipertensivos no previenen la preeclampsia, solo tratan la crisis.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: B**

**Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)**

3.01.4.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. El cerclaje se reserva para incompetencia cervical demostrada (antecedente de abortos tardíos o partos prematuros previos recurrentes con cuello dilatado). B) Correcta. El hallazgo incidental de un cuello uterino corto (< 25 mm por ecografía transvaginal, en este caso 18 mm) en una paciente asintomática de 22 semanas es el principal factor de riesgo para parto prematuro espontáneo. La intervención médica de primera línea avalada por el MINSAL y la evidencia científica es la administración de Progesterona natural micronizada por vía vaginal (200 mg al día al acostarse) hasta la semana 36 de gestación, reduciendo significativamente la probabilidad de parto antes de las 34 semanas. C) Incorrecta. Los tocolíticos solo se usan en fase aguda de contracciones activas por 48h, no de forma profiláctica. D) Incorrecta. El reposo exclusivo es ineficaz. E) Incorrecta. La progesterona es el pilar de primera línea.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal**

3.01.5.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. La cesárea de entrada sin confirmar hipoxia es una conducta precipitada e injustificada. B) Correcta. El ciclo de sueño profundo fetal dura normalmente entre 20 y 40 minutos, durante el cual es fisiológico que no se produzcan aceleraciones de la frecuencia cardíaca. La guía de monitorización fetal establece que ante un trazado no reactivo en los primeros 20 minutos con variabilidad normal, se debe prolongar el registro durante 20 minutos adicionales (completando 40 min) y aplicar estímulo vibroacústico o mecánico suave para despertar al feto. Si tras 40 minutos persiste sin reactividad, se procede a realizar un Perfil Biofísico o Doppler. C) Incorrecta. El sulfato de magnesio es neuroprotector o anticonvulsivante en preeclampsia, no indicado aquí. D) Incorrecta. El examen aún no cumple criterios de reactividad. E) Incorrecta. Inadecuado.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

**Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal**

3.01.5.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. Con 2/10 el feto está en asfixia crítica y fallecerá antes de 48 horas. B) Correcta. En el Score de Perfil Biofísico Fetal de Manning, un puntaje de ≤ 4/10 (en este caso 2/10 con oligohidramnios severo) es diagnóstico de asfixia fetal severa inminente y traduce acidosis metabólica profunda. La conducta oficial mandataria e inmediata es la interrupción urgente del embarazo por la vía más expedita (habitualmente cesárea de emergencia en centro terciario con neonatólogo en sala de partos). C) Incorrecta. La hidratación no corrige la asfixia fetal. D) Incorrecta. A las 36 semanas el feto está prácticamente maduro y el riesgo de asfixia supera con creces cualquier beneficio de esperar corticoides. E) Incorrecta. No es una patología infecciosa.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene un RCIU severo (p2 o menos), por lo que se interrumpe a las 34 semanas, por cesárea. RCIU no severo (p3-4: moderado; p5-9: leve) y con Doppler normal: 37 semanas por parto vaginal. Doppler alterado siempre cesárea a las 34 semanas (flujo umbilical ausente en diástole), 30 semanas (flujo reverso en diástole) o 26 semanas (ducto venoso reverso).

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. No es una RCF severa ni requiere cesárea precoz. B) Correcta. El feto presenta una estimación de peso situada entre el percentil 3 y 10 (P6) pero con una velocimetría Doppler completamente normal en todos los lechos vasculares (umbilical, cerebral y uterinas) y líquido amniótico conservado. Esto define con certeza un Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) Constitucional (feto sano genéticamente pequeño sin hipoxia ni falla placentaria). El pronóstico perinatal es equivalente al de un feto con peso adecuado y la conducta médica es el manejo conservador ambulatorio con parto a término espontáneo (semana 39-40), sin necesidad de adelantar el parto ni realizar intervenciones invasivas. C) Incorrecta. La etapa II requiere diástole ausente en la arteria umbilical. D) Incorrecta. No hay sufrimiento fetal. E) Incorrecta. El peso está bajo el percentil 10, lo que define formalmente PEG.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: B**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. No tiene ninguna relación con la madurez pulmonar. B) Correcta. El ductus venoso es el vaso central que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. La aparición de una onda 'a' reversa en el ductus venoso refleja una presión telediastólica muy elevada en el ventrículo derecho por claudicación miocárdica ante acidosis láctica y asfixia terminal (RCF Etapa IV). Es el predictor más potente e independiente de muerte fetal intrauterina en menos de 24 a 48 horas. La conducta obligatoria es la interrupción urgente del embarazo mediante cesárea, previa administración de neuroprotección con Sulfato de Magnesio (por ser < 32 semanas) y corticoides. C) Incorrecta. Es el signo de máxima gravedad en medicina materno-fetal. D) Incorrecta. La glucosa no revierte la falla ventricular en un feto asfíctico. E) Incorrecta. Esperar 2 semanas causaría el óbito fetal.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: D**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: E**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

El doppler ducto venoso alterado es ominoso (también el OHA severo y el doppler umbilical con flujo ausente o reverso en diástole).

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: C**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

El retraso del crecimiento intrauterino se estudia con Doppler umbilical, como examen de elección (permite diferenciar el PEG del RCIU y además determina la gravedad del RCIU, de manera de determinar la edad de interrupción). Varias de las otras opciones (D y E) serán correctas, dependiendo del resultado del doppler.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: E**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de detención del crecimiento deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por tanto, en este caso, se debe seguir controlando con el Doppler semanal. Si tuviera menos de 34 semanas sí se darían corticoides. El PBF probablemente también se pediría.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: C**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler maternofetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir por cesárea (por tener ya 37 semanas). Revisar manejo y edades de interrupción del RCIU

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: B**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Es un RCIU, con criterios de interrupción (mayor a 37 semanas y además OHA y además detención del crecimiento). Se prefiere la cesárea para evitar el estrés del trabajo de parto.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

**Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler**

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.

---

## BLOQUE 2 PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D** **Hiperemesis gravídica**

3.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Es una hiperemesis gravísica clásica.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: C**

**Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad**

3.01.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: C**

**Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad**

3.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La HTA crónica se diagnostica antes de la semana 20. B) Incorrecta. La hipertensión gestacional no presenta proteinuria significativa (< 300 mg/24h). C) Correcta. La paciente presenta hipertensión arterial de novo diagnosticada después de la semana 20 (semana 32), asociada a proteinuria significativa (450 mg en 24 horas, umbral ≥ 300 mg), en ausencia de síntomas premonitorios de eclampsia o daño de órgano blanco hematológico, hepático o renal (plaquetas normales, enzimas hepáticas normales, creatinina normal y PA < 160/110). Esto configura la definición exacta de Preeclampsia sin Criterios de Severidad. D) Incorrecta. El síndrome HELLP requiere hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia < 100.000. E) Incorrecta. No tiene síntomas neurológicos.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: C**

**Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad**

3.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Es el fármaco de primera línea seguro. B) Incorrecta. Es un antihipertensivo central con amplísimo perfil de seguridad en embarazo. C) Correcta. Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA, como Enalapril) y los Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA-II, como Losartán) están absolutamente contraindicados en el embarazo. Durante el 2.° y 3.er trimestre, el bloqueo del sistema renina-angiotensina fetal causa disminución crítica de la perfusión renal del feto, produciendo anuria, oligohidramnios severo (secuencia de Potter), hipoplasia pulmonar letal, hipocalvaria ósea y muerte perinatal. D) Incorrecta. Es un bloqueador de canales de calcio seguro. E) Incorrecta. Vasodilatador seguro en crisis hipertensiva.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: A**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio** 3.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Preeclampsia severa a ≥34 semanas: hospitalización + control de PA (labetalol o hidralazina EV) + sulfato de magnesio para prevenir eclampsia + interrupción del embarazo una vez estabilizada.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: C**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio** 3.01.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una eclamsia, en contexto de una preclamsia severa. El manejo sigue el siguiente orden: 1. Estabilizar a la paciente y 2. Interrumpir el embarazo. La estabilización también Gene un orden: ABC, luego MgSO4 EV y luego labetalol EV si PA >160/110 (en la práctica se hace todo junto). Aunque en la práctica se hace una cesárea, lo correcto académicamente es que la interrupción del embarazo debe privilegiar la vía vaginal (menos sangrado y estrés quirúrgico), a menos que haya signos de sufrimiento fetal, no se pueda estabilizar a la madre o tenga un cuello cerrado y largo (Bishop < 6-7), ya que demoraría mucho el parto, el que idealmente debe ocurrir antes de que pasen 24 horas desde la eclamsia. La maduración pulmonar puede estar indicada en este caso, por tener menos de 34 semanas, pero no alcanzará a hacer efecto (demora 48 horas).

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: B**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio** 3.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Aumentar el magnesio provocaría paro respiratorio y cardíaco inminente. B) Correcta. La paciente presenta una Intoxicación Aguda por Sulfato de Magnesio, manifestada por la tríada clásica: abolición del reflejo rotuliano (ocurre con magnesemia > 8-10 mEq/L), bradipnea/depresión respiratoria con FR < 12 rpm (ocurre con niveles > 10-12 mEq/L) y oliguria (< 30 mL/h) que favorece la acumulación del fármaco al excretarse 100% por vía renal. La conducta inmediata de emergencia consiste en suspender de inmediato la infusión de sulfato de magnesio y administrar el antídoto específico: Gluconato de Calcio al 10% (1 ampolla de 10 mL = 1 gramo) administrado por vía endovenosa lenta en 3 a 5 minutos para antagonizar el bloqueo neuromuscular. C) Incorrecta. El diazepam empeoraría la depresión respiratoria. D) Incorrecta. El gluconato de calcio revierte el bloqueo; la intubación solo se requiere si persiste el paro respiratorio. E) Incorrecta. Los diuréticos no revierten la toxicidad aguda.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: C**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio** 3.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La hepatitis no presenta hemólisis microangiopática ni plaquetopenia con hipertensión arterial. B) Incorrecta. La epigastralgia en preeclampsia refleja distensión de la cápsula hepática de Glisson. C) Correcta. El cuadro clínico y analítico cumple estrictamente los criterios diagnósticos del Síndrome HELLP (Tennessee): Hemólisis microangiopática (esquistocitos, LDH > 600 U/L, bilirrubina indirecta elevada), Enzimas hepáticas elevadas (AST/ALT > 70 U/L) y Plaquetopenia (< 100.000/mm³), en una paciente con hipertensión severa y dolor en cuadrante superior derecho. El síndrome HELLP es una emergencia obstétrica que requiere hospitalización inmediata en UCI/ARO, profilaxis con Sulfato de Magnesio, control antihipertensivo y la interrupción expedita del embarazo (independiente de la edad gestacional), que constituye el único tratamiento causal curativo. D) Incorrecta. El contexto hipertensivo del tercer trimestre define HELLP. E) Incorrecta. El hígado graso cursa con hipoglicemia severa, hiperuricemia extrema y coagulopatía precoz.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio**

3.01.2.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El nitroprusiato produce toxicidad fetal por cianuro/tiocianato y se reserva como último recurso ante edema pulmonar masivo refractario. B) Correcta. Para el manejo agudo de la crisis hipertensiva severa en el embarazo (PA ≥ 160/110 mmHg), el fármaco endovenoso de primera línea y de elección absoluta es el Labetalol EV. Se inicia con un bolo de 20 mg EV directo en 2 minutos; si a los 10-20 minutos la PA persiste en rango severo, se administra un segundo bolo de 40 mg, y posteriormente 80 mg cada 10-20 minutos hasta una dosis máxima de 220-300 mg. La meta es reducir la PA a 140-150 / 90-100 mmHg para prevenir la hemorragia cerebral materna sin comprometer la perfusión placentaria. C) Incorrecta. Los IECA están absolutamente contraindicados en el embarazo. D) Incorrecta. La furosemida disminuye el volumen intravascular y contrae la volemia. E) Incorrecta. La vía sublingual de nifedipino está proscrita por riesgo de caída tensional precipitada no controlada, muerte fetal y ACV materno.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

**Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio**

3.01.2.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. No es la causa principal en eclampsia. B) Correcta. En las pacientes con eclampsia y crisis hipertensivas severas del embarazo, la complicación fatal más frecuente que explica más del 60-70% de las muertes maternas es el Accidente Cerebrovascular Hemorrágico (Hemorragia Intracerebral masiva secundaria al fallo de la autorregulación vascular cerebral ante presiones arteriales extremas). Por esta razón, el control enérgico de la crisis hipertensiva con Labetalol o Nifedipino y la profilaxis con Sulfato de Magnesio son de máxima urgencia vital. C) Incorrecta. La injuria renal causa morbilidad pero rara vez mortalidad inmediata. D) Incorrecta. Extremadamente raro. E) Incorrecta. Es una catástrofe del parto pero no secundaria a eclampsia.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: E**

**Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia**

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene una glicemia mayor a 105 (ahora el corte es 100). Si fuera menor a 100 se observa, si es mayor, se repite. El TTGO se pide a las 28 semanas y luego a las 32 si hay macrosomía, PHA o antecedentes de DMG en otro embarazo.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: C**

**Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia**

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El valor a las 2 horas está alterado (≥ 140 mg/dL). B) Incorrecta. En el embarazo no existe la categoría de 'intolerancia' separada; ≥ 140 mg/dL a las 2h es formalmente Diabetes Gestacional. C) Correcta. La norma chilena del MINSAL establece que un valor de glicemia a las 2 horas post-carga de 75 g de glucosa ≥ 140 mg/dL en el segundo trimestre es diagnóstico categórico de Diabetes Gestacional. El pilar de tratamiento inicial es la terapia médico-nutricional con dieta normocalórica fraccionada y automonitoreo de glicemias capilares pre y postprandiales durante 1 a 2 semanas antes de evaluar la necesidad de insulina. D) Incorrecta. La diabetes pregestacional se pesquisa en el primer trimestre con glicemias ≥ 126 mg/dL. E) Incorrecta. La metformina no es el fármaco de primera línea de elección según el MINSAL; si la dieta fracasa se usa insulina.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: B**

**Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia**

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Dejar a la paciente con hiperglicemias postprandiales no controladas aumentará el riesgo de macrosomía y muerte fetal. B) Correcta. El criterio estándar para iniciar farmacoterapia en Diabetes Gestacional es la presencia de más del 20% de los controles glucémicos por encima de las metas terapéuticas (en este caso 8 de 28 = 28.5% alterados tras 2 semanas de dieta). El tratamiento farmacológico de elección indiscutido en Chile es la Insulina humana (NPH y/o rápida), que logra un control metabólico óptimo sin atravesar la barrera placentaria. C) Incorrecta. El ayuno genera cetonemia y desnutrición fetal. D) Incorrecta. La glibenclamida atraviesa la placenta y causa hiperinsulinismo e hipoglicemia neonatal severa prolongada. E) Incorrecta. La interrupción precoz sin intentar optimizar el control no está justificada.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: B**

**Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia**

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Desarrollan hipoglicemia por exceso de insulina fetal, no hiperglicemia. B) Correcta. La glucosa materna atraviesa libremente la placenta por difusión facilitada, mientras que la insulina materna no la cruza. La hiperglicemia fetal crónica estimula la hipertrofia e hiperplasia de los islotes de células beta pancreáticas fetales con secreción masiva de insulina fetal. Al nacer y clampear el cordón umbilical, el suministro continuo de glucosa materna cesa de forma inmediata, pero los niveles de insulina del neonato permanecen marcadamente elevados, provocando una rápida captación de glucosa celular y una caída crítica de la glicemia (< 40-45 mg/dL) en las primeras 1 a 4 horas de vida. C) Incorrecta. No es autoinmune. D) Incorrecta. Es una malformación estructural asociada a oligoamnios extremo. E) Incorrecta. Suelen desarrollar hipocalcemia e hipomagnesemia.

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

**Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia**

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El umbral chileno en ayunas en el primer trimestre es 100 mg/dL. B) Correcta. La guía perinatal del MINSAL establece que una glicemia en ayunas en el primer trimestre entre 100 y 125 mg/dL comprobada en dos oportunidades en días distintos es diagnóstica de Diabetes Gestacional de inicio precoz. Requiere ingreso inmediato a programa de diabetes y embarazo para terapia nutricional y automonitoreo sin esperar la semana 24. C) Incorrecta. La diabetes pregestacional manifiesta requiere glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL en dos ocasiones. D) Incorrecta. Es formalmente una diabetes gestacional. E) Incorrecta. Dos tomas alteradas confirman el diagnóstico.

**PREGUNTA 34** **Respuesta: D**

**Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico**

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasas alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

**PREGUNTA 35** **Respuesta: B**

**Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico**

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. La erupción polimorfa (PUPPP) presenta pápulas y placas eritematosas en estrías abdominales con respeto periumbilical. B) Correcta. El prurito palmo-plantar nocturno sin lesiones primarias, transaminasas elevadas y ácidos biliares séricos ≥ 40 umol/L (54 umol/L) confirma el diagnóstico de Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE) Severa. El tratamiento farmacológico de elección avalado internacionalmente y por el MINSAL es el Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a dosis de 10 a 15 mg/kg/día por vía oral, el cual depura los ácidos biliares tóxicos y alivia el prurito materno. Además, por ser severa (≥ 40 umol/L), se debe programar la interrupción a las 36 semanas. C) Incorrecta. El hígado graso cursa con insuficiencia hepática, hipoglicemia y coagulopatía. D) Incorrecta. La escabiosis presenta surcos acarianos interdigitales y prurito familiar. E) Incorrecta. No tiene hipertensión ni proteinuria.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

**Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico**

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Los ácidos biliares no alteran la física del ultrasonido. B) Correcta. En la Colestasia Intrahepática del Embarazo, a diferencia del RCF o la preeclampsia donde existe una insuficiencia placentaria crónica progresiva detectable con Doppler, el óbito fetal ocurre típicamente de forma aguda, súbita e impredecible en fetos con crecimiento y líquido amniótico normales. El mecanismo patogénico es la toxicidad directa de los ácidos biliares sobre los miocardiocitos fetales (generando arritmias cardíacas fatales) y vasoespasmo agudo de las venas de la placa coriónica. Por ello, un RBNE normal no predice la sobrevida a corto plazo y la única estrategia eficaz para evitar el óbito es la interrupción programada del embarazo entre las 36 y 38 semanas según niveles de ácidos biliares. C) Incorrecta. La FCF basal suele ser normal. D) Incorrecta. El feto tiene riesgo severo de muerte intrauterina. E) Incorrecta. El UDCA no altera el RBNE.

**PREGUNTA 37** **Respuesta: E** Presentaciones fetales anómalas 3.01.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una presentación de cara, que se maneja con cesárea, salvo que sea mento- anterior, que no es el caso.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: C**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un aborto séptico e incompleto, con restos ovulares retenidos. Se maneja con antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuación uterina mediante curetaje o AMEU.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En el aborto incompleto el OCI está permeable y se observan restos ovulares desorganizados, no un embrión vital con LCF presentes. B) Correcta. El cuadro clásico de metrorragia de la primera mitad del embarazo con OCI cerrado y visualización ecográfica de un embrión con actividad cardíaca presente y normal (LCF +) corresponde a una Amenaza de Aborto. La conducta recomendada por MINSAL consiste en descartar patología infecciosa cervical o urinaria concomitante, indicar reposo físico y reposo sexual (abstinencia), y seguimiento ambulatorio. No se aconseja el uso rutinario de progesterona si no hay antecedentes de abortos recurrentes. C) Incorrecta. El embrión está vivo con LCF presentes; el misoprostol provocaría un aborto. D) Incorrecta. El saco está normoinserto intrauterino, descartando embarazo ectópico. E) Incorrecta. El aborto inevitable cursa con cuello dilatado y membranas rotas, lo cual no ocurre aquí.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Realizar un legrado instrumental a ciegas sobre un útero séptico friable sin impregnación antibiótica previa desencadena una bacteriemia masiva que conduce a shock séptico refractario y aumenta enormemente el riesgo de perforación uterina. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, dolor hipogástrico, loquios o secreción purulenta fétida y útero doloroso subinvolucionado tras un aborto configura un Aborto Séptico. Es una emergencia infectológica mayor. La conducta médica oficial consiste en hospitalización inmediata en UTI/UCI, reanimación con fluidos, toma de cultivos, inicio precoz de antibioticoterapia parenteral de amplio espectro con triple asociación (ej. Ceftriaxona/Gentamicina + Ampicilina + Metronidazol o Clindamicina) para esterilizar el torrente sanguíneo, y posteriormente (a las 2 a 4 horas de iniciada la cobertura antibiótica) proceder a la evacuación uterina instrumental mediante AMEU o curetaje suave. C) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente proscritos en el aborto séptico. D) Incorrecta. El misoprostol solo no trata la infección bacteriana invasiva ni garantiza la evacuación rápida en sepsis. E) Incorrecta. La histerectomía se reserva para casos de falla multiorgánica refractaria, gangrena miometrial por Clostridium o perforación uterina comprobada.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: C**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la amenaza de aborto el OCI está estrictamente cerrado. B) Incorrecta. En el aborto retenido el OCI está cerrado y el tejido no está siendo expulsado activamente. C) Correcta. La conjunción de metrorragia activa, cuello con OCI permeable/abierto donde se palpan tejidos ovulares o restos, y confirmación ecográfica de restos intrauterinos desorganizados define el Aborto Incompleto. El tratamiento consiste en la evacuación de la cavidad mediante AMEU o Misoprostol. D) Incorrecta. En el aborto completo el cuello ya se ha cerrado y la ecografía muestra un endometrio delgado y lineal sin restos. E) Incorrecta. Aunque la mola muestra restos vesiculares, la presencia de OCI abierto con expulsión de restos fetoplacentarios típicos corresponde a la definición clínica de aborto incompleto.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La ley chilena no exige que haya denuncia policial ni fallo condenatorio; basta la declaración de la mujer y la evaluación del equipo de salud multidisciplinario. B) Correcta. La Ley 21.030 establece para la tercera causal (violación) un límite estricto de edad gestacional de hasta 12 semanas de gestación en mujeres mayores de 14 años, y se extiende hasta las 14 semanas de gestación cuando la víctima es una menor de 14 años. C) Incorrecta. El profesional que manifiesta objeción de conciencia tiene el deber legal estricto de derivar de inmediato a la paciente a un equipo o institución que realice la prestación. D) Incorrecta. La única causal sin límite temporal de edad gestacional es la Causal 1 (riesgo vital materno) y la Causal 2 (inviabilidad fetal letal). E) Incorrecta. No requiere aprobación de comité ético, sino verificación médica y del equipo psicosocial.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aborto provocado" como urgencia clínica (3.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A**

**Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030**

3.01.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), que se debe interrumpir de inmediato por la vía más expedita, la que, por no tener dilatación cervical, es la cesárea de urgencia. La única excepción, que se puede hospitalizar y observar con mucho cuidado, es que sea menor a 34 semanas, con sangrado escaso, madre bien, feto bien y sin dolor ni contracciones (en otras palabras, < 34 semanas con un poquito y todo tranquilizador).

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere GES

Anemia ferropénica en embarazo (Hb <11 g/dL + microcitosis + ferritina baja): tratamiento de primera línea = hierro oral elemental 200 mg/día. Hierro EV se reserva para intolerancia oral, malabsorción o anemia severa. Transfusión solo en anemia grave sintomática.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: B**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La laparotomía abierta y la histerectomía son procedimientos mutilantes completamente desproporcionados y contraindicados para una paciente joven y estable con un ectópico no roto. B) Correcta. La paciente presenta un embarazo ectópico tubárico no roto confirmado por β-hCG > 2.000 UI/L con útero vacío. Cumple con todos los criterios de elegibilidad para el tratamiento médico con Metotrexato a dosis única: hemodinámicamente estable, β-hCG sérica menor a 5.000 UI/L (3.200 UI/L), masa anexial menor de 3.5 cm (2.6 cm), ausencia de latidos cardíacos fetales, sin hemoperitoneo y con función hepática/renal y hemograma normales. Este abordaje médico preserva la indemnidad tubárica con una tasa de resolución cercana al 90%. C) Incorrecta. El manejo expectante solo se permite con β-hCG muy baja (< 1.000 UI/L) y en franco descenso espontáneo confirmado en 48 horas. D) Incorrecta. El embarazo no está en la cavidad uterina; el legrado no resolverá el cuadro y expondrá a la trompa a rotura por retraso diagnóstico. E) Incorrecta. La progesterona no tiene indicación y favorecería el crecimiento del trofoblasto ectópico.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: B**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El metotrexato está absolutamente contraindicado ante sospecha de rotura e inestabilidad hemodinámica; su efecto tarda días en manifestarse y la paciente fallecería en minutos. B) Correcta. La combinación de dolor abdominal hiperagudo, síncope, hipotensión severa (75/40), taquicardia extrema (135 lpm), palidez y vientre peritoneal con test de gestación positivo constituye un cuadro clásico de Embarazo Ectópico Roto en Shock Hipovolémico (Hemoperitoneo Masivo). Constituye una emergencia quirúrgica de riesgo vital absoluto. La conducta consiste en soporte hemodinámico inmediato con accesos venosos gruesos, fluidoterapia con cristaloides tibios, hemoderivados (glóbulos rojos) y traslado inmediato a pabellón para laparotomía de urgencia para cohibir el sangrado mediante salpingectomía. C) Incorrecta. Una paciente inestable nunca debe llevarse a un tomógrafo por riesgo de PCR fuera de pabellón. D) Incorrecta. Retrasar la cirugía para esperar una prueba de laboratorio es una negligencia médica letal. E) Incorrecta. El legrado no detiene la hemorragia tubárica intraperitoneal.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: B**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.1.002 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El aumento transitorio de la β-hCG entre el Día 1 y el Día 4 es fisiológico debido a la lisis trofoblástica inicial inducida por el fármaco, y no se considera fracaso. B) Correcta. El cálculo matemático muestra: del Día 4 (2.650 UI/L) al Día 7 (2.100 UI/L) hubo una reducción de 550 UI/L. El porcentaje de reducción es: (550 / 2.650) * 100 = 20.75%. Como 20.75% es superior al umbral exigido del 15% de reducción entre el día 4 y el día 7, el tratamiento se clasifica formalmente como exitoso. La conducta médica es continuar la monitorización ambulatoria semanal de la β-hCG sérica hasta alcanzar concentraciones indetectables (< 5 UI/L). C) Incorrecta. El descenso fue del 20.75%, que supera el 15%. D) Incorrecta. No está de alta; el seguimiento semanal es obligatorio hasta la negativización total. E) Incorrecta. La leucovorina no está indicada en el esquema de dosis única.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: C**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.1.002 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. La porción ampular se rompe entre las 6 y 8 semanas. B) Incorrecta. La porción ístmica es la más estrecha y se rompe muy precozmente (antes de las 6 semanas). C) Correcta. El embarazo ectópico intersticial (o cornual) se implanta en el segmento intramural de la trompa que atraviesa el miometrio uterino. Debido a la mayor distensibilidad de las fibras miometriales que rodean este segmento, el saco gestacional puede crecer durante más tiempo, rompiéndose típicamente en forma tardía entre las 12 y 16 semanas de gestación. Dado que en esa zona se localiza la anastomosis entre la arteria uterina y la arteria ovárica, su rotura causa una hemorragia cataclísmica y exanguinante masiva, con alta mortalidad materna. D) Incorrecta. La porción fímbrica suele culminar en aborto tubárico hacia la cavidad abdominal. E) Incorrecta. El ectópico cervical produce hemorragia vaginal indolora masiva, no hemoperitoneo.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: C**

**Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico**

3.01.2.005 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere | GES

Embarazo ectópico roto

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

**Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento**

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. La histerectomía total se reserva para pacientes añosas con paridad satisfecha que no desean fertilidad, y la salpingooforectomía es innecesaria porque los ovarios regresan espontáneamente al normalizarse la hCG. B) Correcta. El tratamiento de elección para la mola hidatiforme es la evacuación inmediata de la cavidad uterina mediante aspiración al vacío (aspiración mecánica o AMEU) bajo goteo de oxitocina, enviando todo el tejido a confirmación anatomopatológica. Se prefiere la aspiración sobre el legrado instrumental cortante por el elevado riesgo de hemorragia profusa y perforación del miometrio reblandecido. C) Incorrecta. El uso de misoprostol o agentes inductores de contracciones aislados aumenta drásticamente el riesgo de embolización pulmonar de tejido trofoblástico. D) Incorrecta. La quimioterapia no es el tratamiento inicial de la mola hidatiforme; solo se reserva para las pacientes que desarrollan una Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) durante el seguimiento. E) Incorrecta. Los quistes tecaluteínicos no deben puncionarse ni extirparse; son una respuesta fisiológica benigna que involuciona espontáneamente al evacuar la mola.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

**Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento**

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Los valores de β-hCG se estancaron y comenzaron a ascender entre la semana 2 y 4, lo que descarta una evolución normal. B) Correcta. El criterio diagnóstico de la FIGO para Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) se cumple cuando la β-hCG se mantiene en meseta durante tres semanas consecutivas o cuando se constata un ascenso de los valores en dos o más mediciones sucesivas durante el seguimiento postmolar. En esta paciente, los niveles pasaron de 3.500 a 3.600 y luego a 3.800 UI/L, lo cual confirma NTG (mola invasora o coriocarcinoma). La conducta médica obligatoria es etapificar a la paciente (mediante examen clínico, TAC de tórax-abdomen-pelvis) para calcular el score pronóstico FIGO e iniciar tratamiento con quimioterapia (generalmente Metotrexato si es bajo riesgo). C) Incorrecta. A las 4 semanas de una mola no se trata de un nuevo embarazo normal, sino de proliferación trofoblástica activa invasora. D) Incorrecta. La infección no produce elevación de la β-hCG. E) Incorrecta. Un segundo legrado no cura la NTG y eleva el riesgo de perforación y hemorragia sin beneficio demostrado.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: B**

**Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda**

3.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la embarazada la bacteriuria asintomática siempre debe tratarse para evitar la progresión a pielonefritis. B) Correcta. El hallazgo de ≥ 100.000 UFC/mL en una gestante asintomática define Bacteriuria Asintomática. La norma oficial del MINSAL y la evidencia médica indican tratamiento antibiótico obligatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días (o Nitrofurantoína por 7 días), seguido de un urocultivo de control a los 7 a 14 días post-tratamiento para certificar la curación microbiológica. El tratamiento reduce la incidencia de pielonefritis de un 30-40% a menos del 3-5%. C) Incorrecta. La vía endovenosa se reserva para pielonefritis sintomática. D) Incorrecta. El arándano no sustituye la terapia antimicrobiana curativa. E) Incorrecta. Postergar el tratamiento expone a la paciente a pielonefritis en el segundo trimestre.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: B**

**Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda**

3.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La pielonefritis aguda en el embarazo NUNCA se trata en forma ambulatoria por el alto riesgo de bacteriemia, shock séptico, SDRA y parto prematuro. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, calofríos y puñopercusión lumbar positiva en el embarazo es diagnóstica de Pielonefritis Aguda. Toda pielonefritis en el embarazo requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para hidratación parenteral vigorosa, monitorización de la dinámica uterina y bienestar fetal, y antibioticoterapia endovenosa empírica inmediata con Cefalosporinas de 1.ª o 3.ª generación (Cefazolina 1 g c/8h EV o Ceftriaxona 1 a 2 g c/24h EV), manteniéndola hasta 48 horas afebril y completando 14 días por vía oral. C) Incorrecta. Las fluoroquinolonas están contraindicadas en el embarazo por toxicidad sobre el cartílago de crecimiento fetal. D) Incorrecta. El parto no está indicado; la infección se trata médicamente y las contracciones suelen ceder al enfriar el cuadro infeccioso. E) Incorrecta. Negligente ante una infección sistémica.

---

## BLOQUE 4 METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: B**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La ecografía transvaginal es el método diagnóstico de elección y es completamente segura, ya que el transductor se ubica en el fondo de saco vaginal anterior a más de 2 cm del cuello. B) Correcta. En toda paciente que consulta por metrorragia del tercer trimestre con sospecha de placenta previa (sangrado indoloro, útero blando, feto reactivo), el TACTO VAGINAL DIGITAL está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO. La introducción del dedo a través del canal cervical puede desgarrar la masa placentaria o vasos nutricios de gran calibre, provocando una hemorragia masiva exanguinante inmediata que amenaza la vida de la madre y del feto. C) Incorrecta. Instalar vías venosas gruesas es parte esencial de la estabilización. D) Incorrecta. La especuloscopía suave permite certificar si la sangre proviene de la cavidad uterina o de una lesión cervical/vaginal local. E) Incorrecta. El estudio hematológico y de coagulación es imperativo.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa no produce dolor intenso ni hipertonía uterina leñosa. B) Correcta. La combinación de metrorragia con sangre oscura, dolor abdominal intenso y continuo, hipertonía uterina leñosa ('útero en tabla') y sufrimiento fetal agudo (bradicardia fetal y DIP II) en una paciente hipertensa es la presentación clásica del Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI o Abruptio Placentae). Representa una emergencia obstétrica crítica con altísimo riesgo de muerte fetal intrauterina y coagulopatía de consumo materna (CID). Con feto vivo y viable a las 35 semanas, la conducta mandatoria es la interrupción inmediata mediante cesárea de urgencia junto a reanimación materna. C) Incorrecta. En la vasa previa el sangrado es indoloro tras romper membranas y el útero no está hipertónico. D) Incorrecta. Los tocolíticos están contraindicados ante sospecha de desprendimiento placentario. E) Incorrecta. El cuadro es netamente obstétrico de riesgo vital.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: C**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa no produce cese súbito de contracciones ni ascenso de la presentación. B) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico debuta con colapso cardiopulmonar fulminante, hipoxemia y convulsiones sin ascenso fetal palpable. C) Correcta. El dolor desgarrador súbito seguido por el cese instantáneo de las contracciones uterinas, shock hipovolémico materno, ascenso y desaparición de la presentación fetal en la pelvis, y palpación muy superficial de las partes fetales en el abdomen en una paciente con cicatriz de cesárea anterior bajo oxitócicos es patognomónico de Rotura Uterina Completa. El feto ha sido expulsado hacia la cavidad peritoneal. Requiere laparotomía exploradora inmediata de emergencia para extracción fetal y hemostasia quirúrgica materna. D) Incorrecta. En el DPPNI el útero se mantiene hipertónico y duro, no cesan las contracciones ni asciende la presentación fetal a la cavidad abdominal. E) Incorrecta. La inversión uterina ocurre en el alumbramiento o postparto con masa que protruye por vagina.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. La secuencia clínica patognomónica de metrorragia que aparece inmediatamente tras la rotura de membranas ovulares (amniotomía o amniorrexis) asociada a sufrimiento fetal agudo severo e instantáneo (bradicardia severa o patrón sinusoidal), en una madre totalmente asintomática y con útero relajado, es la manifestación clásica de la Rotura de Vasa Previa. Los vasos umbilicales aberrantes velamentosos que atraviesan el orificio cervical interno se desgarran al romperse las membranas; la sangre es de origen fetal, por lo que el feto sufre una exanguinación fulminante en pocos minutos. Exige cesárea emergente inmediata. B) Incorrecta. La placenta previa sangra antes de romper membranas de forma espontánea y no se asocia al acto de la amniotomía de vasos aberrantes. C) Incorrecta. El DPPNI se asocia a dolor intenso e hipertonía uterina, ausentes en este caso. D) Incorrecta. La laceración de cuello no causa bradicardia fetal extrema inmediata. E) Incorrecta. La corioamnionitis cursa con fiebre materna y taquicardia fetal.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: E**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene una placenta previa sintomática, por lo que debe interrumpirse por cesárea. Si bien está en buenas condiciones, ya tiene más de 34 semanas, por lo que se interrumpe sin mayor riesgo de complicaciones por prematurez.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: D**

**Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa**

3.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Rotura uterina (dolor súbito diferente a contracciones + bradicardia fetal + antecedente de cicatriz uterina): emergencia obstétrica máxima. Cesárea de urgencia INMEDIATA. El fórceps/vacuum están absolutamente contraindicados. Sin tratamiento puede ser fatal para madre y feto.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 98). Evalúa el manejo clínico de Embarazo con edad gestacional dudosa según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: B**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En < 34 semanas sin infección el manejo es conservador; el tacto vaginal arrastra gérmenes y la inducción prematura expone al feto a morbimortalidad severa. B) Correcta. En una RPM pretérmino entre 24 y 34 semanas sin signos de infección ovular, la conducta estándar recomendada por el MINSAL es el manejo expectante en una Unidad de ARO. Esto incluye la administración de Betametasona (12 mg IM c/24h x 2 dosis) para acelerar la maduración pulmonar fetal y reducir hemorragia intraventricular, y el esquema de antibioticoterapia de latencia (Ampicilina EV + Eritromicina EV por 48 horas, seguido de Amoxicilina + Eritromicina/Azitromicina oral hasta completar 7 días) para prolongar el tiempo de latencia libre de parto y disminuir el riesgo de infección neonatal. C) Incorrecta. La RPM pretérmino exige hospitalización estricta. D) Incorrecta. La cesárea no está indicada de urgencia en ausencia de sufrimiento fetal o corioamnionitis. E) Incorrecta. La tocolisis prolongada no mejora los resultados perinatales y está contraindicada.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La tocolisis en corioamnionitis perpetúa un foco infeccioso que puede costar la vida materna y fetal por shock séptico. B) Correcta. La paciente cumple estrictamente todos los criterios de Gibbs para Corioamnionitis Clínica (fiebre materna alta, taquicardia materna y fetal, dolor a la palpación uterina, líquido amniótico purulento/fétido y leucocitosis con desviación izquierda). La corioamnionitis es una EMERGENCIA OBSTÉTRICA que contraindica cualquier conducta expectante o retraso. La conducta obligatoria es la hospitalización en sala de partos/quirófano, inicio inmediato de antibioticoterapia EV de amplio espectro (Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg/día EV) y la INTERRUPCIÓN INMEDIATA del embarazo por la vía más expedita (habitualmente inducción oxitócica si el parto es rápido, o cesárea si hay distocia o sufrimiento fetal severo). C) Incorrecta. Los corticoides están contraindicados ante infección intraamniótica manifiesta. D) Incorrecta. Esperar cultivos ante un diagnóstico clínico evidente de sepsis ovular es una mala praxis letal. E) Incorrecta. La conducta expectante está proscrita ante corioamnionitis.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. En una paciente con Rotura Prematura de Membranas a partir de las 34 semanas de gestación (en este caso 36 semanas), la conducta consensuada oficial por el MINSAL y la FIGO es la INTERRUPCIÓN INMEDIATA DEL EMBARAZO mediante inducción del parto (mediante oxitocina o maduración previa con misoprostol si el Bishop es desfavorable). A esta edad gestacional los riesgos infecciosos materno-fetales superan a los riesgos de la prematuridad tardía. B) Incorrecta. Los corticoides no están indicados en mayores de 34 semanas en el contexto de RPM. C) Incorrecta. Los antibióticos de latencia se usan en < 34 semanas; en ≥ 34 semanas solo se aplica profilaxis contra SGB si el cultivo es positivo o la latencia supera las 12-18 horas. D) Incorrecta. La tocolisis está formalmente contraindicada en ≥ 34 semanas. E) Incorrecta. No se puede esperar semanas con membranas rotas por el altísimo riesgo de corioamnionitis.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La especuloscopía estéril es el estándar diagnóstico de elección. B) Correcta. El tacto vaginal digital está terminantemente contraindicado en la sospecha de RPM sin trabajo de parto evidente, ya que introduce bacterias patógenas desde el vestíbulo y vagina profunda hacia el canal endocervical y la cavidad amniótica, reduciendo significativamente el tiempo de latencia y multiplicando por 3 a 5 veces el riesgo de infección intraamniótica (corioamnionitis) y sepsis neonatal temprana. C) Incorrecta. Es una prueba confirmatoria válida y segura. D) Incorrecta. El test de nitrazina es una prueba útil y segura. E) Incorrecta. El test AmniSure es altamente específico y no invasivo.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En amenaza de parto prematuro menor a 34 semanas se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas; el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es tocolítico de segunda línea.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

**Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis**

3.01.2.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

RPM a las 35 semanas: manejo conservador con hospitalización, corticoides (betametasona) para maduración pulmonar, antibióticos profilácticos (ampicilina + eritromicina) y monitoreo fetal estrecho.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección**

3.01.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Embarazo ectópico no complicado: El diagnóstico es un embarazo ectópico no complicado, basado en los niveles de hCG mayores a 3500 y la ausencia de un saco gestacional visible en la ecografía transvaginal. La paciente no tiene contraindicaciones para el metotrexato, ya que el tumor anexial es menor a 4 cm y los niveles de hCG son menores a 5000. El tratamiento de elección en este caso es el metotrexato. Si los niveles de hCG hubieran sido inferiores a 3500, la respuesta habría sido repetir los niveles de hCG en 48 horas. Si el tumor anexial hubiera sido mayor a 4 cm o la hCG mayor a 5000, la respuesta habría sido una salpingectomía por laparoscopía. Si la paciente hubiera estado en shock, la respuesta correcta habría sido la salpingectomía inmediata, ya sea por vía abierta o laparoscópica.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

**Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección**

3.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La paciente tiene un cuadro activo de APP con cérvix marcadamente acortado y dilatado; el manejo ambulatorio es una grave negligencia. B) Correcta. La presencia de dinámica uterina regular con cérvix corto de 16 mm (< 25 mm) a las 30 semanas de gestación confirma una Amenaza de Parto Prematuro. El manejo integral hospitalizado de primera línea incluye: 1) Tocolisis con Nifedipino oral durante 48 horas para frenar las contracciones; 2) Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis para inducir maduración pulmonar y reducir membrana hialina y hemorragia intraventricular; y 3) Sulfato de Magnesio EV para neuroprotección fetal (reducir parálisis cerebral) al tratarse de una gestación menor de 32 semanas. C) Incorrecta. La cesárea inmediata no está indicada en ausencia de sufrimiento fetal agudo o complicación catastrófica; debe intentarse la tocolisis para permitir la acción del corticoide. D) Incorrecta. La indometacina no se utiliza de mantención prolongada ni ambulatoria por sus graves efectos adversos sobre el feto (cierre del ductus y oligohidramnios). E) Incorrecta. El cerclaje de emergencia está contraindicado en presencia de contracciones uterinas activas francas.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: C**

**Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección**

3.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Es la indicación típica de tocolisis para permitir la maduración pulmonar. B) Incorrecta. Situación clásica con indicación formal de freno uterino y corticoides. C) Correcta. La Corioamnionitis Clínica es una contraindicación formal y absoluta para cualquier terapia tocolítica. Intentar detener el parto en presencia de una infección ovular invasiva pone en riesgo inminente la vida de la madre (sepsis, shock séptico) y del feto (muerte intrauterina, asfixia, secuelas neurológicas severas). La conducta mandatoria es la interrupción inmediata del embarazo bajo cobertura antibiótica endovenosa de amplio espectro. D) Incorrecta. El embarazo gemelar con APP puede recibir tocolisis para completar corticoides. E) Incorrecta. La ITU puede desencadenar contracciones; mientras se trata el antibiótico, la tocolisis está indicada por 48 horas si hay APP.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

**Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento**

3.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Embarazo gemelar bicorial biamniótico: En un embarazo gemelar bicorial biamniótico sin complicaciones, la ecografía muestra fetos con pesos similares y sin restricción del crecimiento intrauterino (por encima del percentil 10). Se suele interrumpir a las 38 semanas. La vía del parto depende de la presentación del primer gemelo y la amniocidad. Si el primer gemelo está en posición cefálica y es biamniótico, se puede realizar un parto vaginal (tanto en monocorial como en bicorial). En cambio, si el primer gemelo no está en posición cefálica o si es monoamniótico, se interrumpe por cesárea. Los monocoriales biamnióticos, se interrumpen a las 36 semanas. Los monoamnióticos, a las 32 a 34 semanas.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

**Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento**

3.01.2.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene buena dinámica (3-5 contracciones cada 10 minutos). Está en presentación cefálica de vérGce (punto de referencia es el occipucio), así que no hay distocia de presentación. No Gene criterios de macrosomía fetal (mayor a 4.500 gramos). Tiene posición occipital posterior persistente, lo que es compaGble con una distocia de posición. La posición es la rotación del feto en relación a la pelvis (se describe con el punto de referencia, en relación a una parte de la pelvis). La mayoría de los partos se dan en posición anterior: “occipito púbica” u “occipito ilíaca anterior”, en cambio, las posiciones transversas y posteriores suelen demorar más y, si persisten, se consideran una distocia de posición. No se debe confundir la posición transversa (ej. occipito ilíaca transversa), que puede demorar, pero Gene opción de parto vaginal, con la con presentación transversa (ej. acromio púbica), que obliga a la cesárea desde el inicio.

## BLOQUE 5 PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un embarazo molar, confirmado con la ecografía. La HCG muy elevada también la sugiere, al igual que el útero de tamaño mucho mayor al esperado para su edad gestacional (suprapúbico equivale a 12 semanas).

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La maniobra de Kristeller está absolutamente contraindicada en la distocia de hombros por riesgo de rotura uterina y fracturas fetales, al igual que la tracción brusca que rompe el plexo braquial. B) Correcta. Ante una Distocia de Hombros confirmada por el 'signo de la tortuga', el abordaje sistemático de primera línea universalmente validado (protocolo HELPERR / MINSAL) consiste en: 1) Maniobra de McRoberts (hiperflexión extrema de los muslos de la madre contra el abdomen, lo que reduce el ángulo de inclinación de la pelvis y amplía el diámetro funcional sagital), asociada a 2) Presión Suprapúbica (Maniobra de Mazzanti), ejerciendo presión hacia abajo y hacia el lado con la eminencia tenar para rotar y desimpactar el hombro anterior. Esta combinación resuelve con éxito entre el 70% y 85% de los casos sin secuelas. C) Incorrecta. La maniobra de Zavanelli es un recurso heroico desesperado reservado para el fracaso de todas las maniobras internas. D) Incorrecta. La fractura de clavícula no es una maniobra de primera línea. E) Incorrecta. La sinfisiotomía es una técnica mutilante de último recurso en países sin quirófano disponible.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Las desaceleraciones que coinciden en espejo no indican acidosis ni desprendimiento. B) Correcta. Las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que se inician junto con la contracción uterina, alcanzan su nadir en el acmé de la misma ('imagen en espejo' simétrica) y se normalizan al terminar la contracción corresponden a Desaceleraciones Precoces o Tempranas (DIP I). Están causadas por la compresión mecánica transitoria de la cabeza fetal contra el canal del parto, lo que genera un aumento de la presión intracraneal fetal y estimulación vagal parasimpática con caída de la frecuencia. Tienen carácter totalmente fisiológico y benigno, no se asocian a hipoxia ni acidemia, y permiten continuar la evolución normal del parto vaginal. C) Incorrecta. La insuficiencia placentaria e hipoxia se manifiesta como DIP II (tardías). D) Incorrecta. La compresión de cordón produce DIP III (variables en V). E) Incorrecta. La anemia fetal produce trazado sinusoidal oscilatorio.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: C**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La observación expectante ante desaceleraciones tardías con variabilidad ausente causará la muerte fetal o encefalopatía hipóxico-isquémica. B) Incorrecta. Aumentar la oxitocina aumentará las contracciones y asfixiará al feto. C) Correcta. El trazado descrito presenta Desaceleraciones Tardías recurrentes (DIP II) asociadas a pérdida total de la variabilidad fetal, configurando un Patrón de Monitoreo Categoría III (Anormal). Este patrón traduce una hipoxia fetal severa con deuda tisular de oxígeno y acidosis metabólica miocárdica progresiva por insuficiencia útero-placentaria. La conducta obstétrica mandatoria es instaurar de inmediato maniobras de reanimación intrauterina (suspender oxitocina, oxígeno materno, decúbito lateral izquierdo, bolo de cristaloides) y proceder a la resolución inmediata del embarazo mediante cesárea de emergencia. D) Incorrecta. Inadecuado ante un compromiso hipóxico agudo. E) Incorrecta. La peridural puede generar hipotensión materna que agrava la hipoxia fetal.

---

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La parálisis facial se asocia clásicamente a la compresión de la rama mandibular por las cucharas del fórceps. B) Correcta. La Parálisis de Erb-Duchenne es la lesión neurológica obstétrica clásica más común de la distocia de hombros. Ocurre por la distensión excesiva o rotura traumática de las raíces superiores del plexo braquial (C5 y C6) provocada por la tracción axial y balanceo lateral vigoroso ejercido sobre la cabeza fetal cuando el hombro está anclado en la pelvis. El recién nacido adopta la típica postura 'en propina de mozo' (brazo en aducción y rotación interna con antebrazo extendido y pronado). C) Incorrecta. La de Klumpke (C8-T1) compromete la mano y es mucho más rara, típica de tracción excesiva en podálica con brazos en alto. D) Incorrecta. El nervio ciático poplíteo no se afecta en la distocia de hombros. E) Incorrecta. Menos frecuente que la parálisis braquial superior.

---

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Lo más importante es la HCG seriada, para detectar precozmente la aparición de una neoplasia trofoblástica gestacional. Sin embargo, también deberá quedar con ACO, para evitar un embarazo que eleva la HCG y alterará el seguimiento.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: A**

**Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)**

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado**

3.01.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 97). Evalúa el manejo clínico de Macrosomía fetal según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: B**

**Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado**

3.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El misoprostol es seguro en pacientes hipertensas y es el fármaco de elección alternativa. B) Correcta. La Metilergonovina (Ergometrina / Maleato de metilergonovina) es un alcaloide derivado del cornezuelo de centeno que produce vasoconstricción arterial periférica generalizada y contracción tetánica miometrial. Por ende, está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en pacientes con antecedentes de preeclampsia, hipertensión arterial gestacional o crónica y cardiopatía isquémica, debido a que su administración puede precipitar una crisis hipertensiva severa con rotura de vasos cerebrales (ACV hemorrágico), edema agudo de pulmón o infarto agudo de miocardio. En esta paciente hipertensa debe utilizarse Misoprostol o Carbetocina. C) Incorrecta. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico seguro y mandatorio en HPI. D) Incorrecta. La carbetocina es un análogo de la oxitocina y puede utilizarse. E) Incorrecta. El balón de Bakri es un dispositivo mecánico altamente recomendado.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: B**

**Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado**

3.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la atonía el útero está blando y subinvolucionado, mientras que aquí está firme y bien contraído. B) Correcta. La presencia de hemorragia genital activa postparto en presencia de un útero FIRME, BIEN CONTRAÍDO e infraumbilical, con placenta íntegra revisada, orienta con certeza a una causa traumática (Trauma de las 4T: desgarros del cuello uterino, de la pared vaginal o del periné). La conducta obligatoria es trasladar a la paciente a sala de partos o pabellón con buena iluminación, instalar valvas ginecológicas para inspeccionar el cuello uterino en sus 360 grados y las paredes vaginales, y proceder a la hemostasia quirúrgica mediante sutura de los desgarros. C) Incorrecta. Si la placenta estaba completa y el útero está contraído, no se justifica legrado a ciegas. D) Incorrecta. El sangrado rutilante localizado con útero duro descarta coagulopatía primaria. E) Incorrecta. En la inversión uterina el fondo desaparece del abdomen y se palpa una masa en vagina.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: B**

**Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado**

3.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El legrado cortante en un útero atónico no detiene el sangrado vascular miometrial y perfora la pared. B) Correcta. El Balón de Taponamiento Intrauterino (Balón de Bakri) es el procedimiento conservador no quirúrgico de rescate de elección ante la atonía uterina refractaria a fármacos uterotónicos. Se inserta en la cavidad uterina y se insufla con 300 a 500 mL de solución salina, ejerciendo una compresión hidrostática uniforme directa sobre los lechos vasculares miometriales. Logra controlar la hemorragia en más del 80-85% de los casos, evitando la laparotomía y preservando la fertilidad de la mujer. C) Incorrecta. La histerectomía es el último recurso quirúrgico definitivo si fracasan las medidas conservadoras. D) Incorrecta. La heparina aumentaría la hemorragia masiva y mataría a la paciente. E) Incorrecta. Dejar avanzar el shock es negligencia médica.

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

**Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado**

3.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa ocurre antes del parto, no en el postparto. B) Correcta. La combinación de tracción excesiva del cordón sobre un útero relajado, colapso hemodinámico severo con bradicardia paradójica (shock neurogénico por tracción de los nervios peritoneales), desaparición del fondo uterino en el abdomen y exteriorización de una masa carnosa globular por la vagina es el cuadro patognomónico de una Inversión Uterina Puerperal. Constituye una emergencia con altísima mortalidad materna. La conducta consiste en: 1) Suspender inmediatamente cualquier uterotónico; 2) Proporcionar soporte circulatorio y analgesia/anestesia profunda para relajar el anillo cervical constrictor; 3) Realizar la Reposición Manual Inmediata (Maniobra de Johnson), empujando el fondo uterino hacia arriba a través del anillo de inversión hacia la cavidad abdominal; y 4) Una vez corregida la posición, recién iniciar oxitocina para mantener el útero contraído. C) Incorrecta. No es una rotura miometrial sino una invaginación de la pared. D) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico produce colapso respiratorio con hipoxemia severa sin masa exteriorizada en vagina. E) Incorrecta. El cuadro es una emergencia vital mayor.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)**

3.01.1.010 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente contraindicados por el alto riesgo de sepsis y absceso pelviano. B) Correcta. El cuadro de fiebre, dolor uterino, útero subinvolucionado blando y loquios fétidos tras una cesárea corresponde a una Endometritis Puerperal típica. Al tratarse de una infección polimicrobiana que involucra anaerobios estrictos del tracto genital y enterobacterias, el tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la literatura médica internacional es la HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para antibioticoterapia parenteral combinada con Clindamicina (900 mg cada 8h EV) + Gentamicina (5 mg/kg/día EV en dosis única), manteniéndose hasta que la paciente esté 48 horas afebril. C) Incorrecta. El ciprofloxacino oral no cubre adecuadamente la flora anaerobia miometrial y la vía oral es insuficiente. D) Incorrecta. La dosis única es totalmente ineficaz para erradicar una endometritis. E) Incorrecta. Reservado únicamente para sepsis refractaria en UCI.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)**

3.01.1.010 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Suspender la lactancia está formalmente contraindicado porque empeora la estasis láctea. B) Correcta. La presentación de fiebre alta, calofríos y una placa eritematosa caliente sectorial unilateral en una mama en el primer mes del puerperio es diagnóstica de Mastitis Infecciosa Puerperal, causada en más del 90% por Staphylococcus aureus procedente de la orofaringe del lactante. El tratamiento de elección consiste en un antibiótico con cobertura antiestafilocócica (Cloxacilina oral 500 mg c/6h o Cefadroxilo 500 mg c/12h) durante 10 a 14 días. La regla de oro fundamental es que NO se debe suspender la lactancia materna; al contrario, debe mantenerse el amamantamiento frecuente y vaciamiento completo del pecho para evitar la estasis de leche que predispone a la formación de un absceso. C) Incorrecta. El drenaje quirúrgico solo está indicado si se ha formado un absceso fluctuante comprobado ecográficamente. D) Incorrecta. La mastitis infecciosa requiere antibióticos orales obligatorios. E) Incorrecta. La cabergolina para inhibir lactancia es un error grave en una mujer que desea amamantar.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: C**

**Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)**

3.01.2.006 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Es una endometritis puerperal clásica.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: C**

**Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)**

3.01.2.009 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere | GES

Tiene una mastitis puerperal, por lo que solo se deben indicar antibióticos con cobertura de gram positivos (cefazolina endovenosa o amoxicilina + ácido clavulánico oral). Si hubiese tenido un absceso, pues, además se drena. No es necesario suspender la lactancia, sino mejorar la técnica de lactancia.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: B**

**Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada**

3.01.1.012 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. No hay justificación de interrupción; el embarazo es fisiológico y sano. B) Correcta. En toda gestante Rh negativa no sensibilizada (confirmada por un Test de Coombs Indirecto negativo), las guías clínicas de MINSAL y los consensos internacionales indican la administración profiláctica rutinaria de Inmunoglobulina Anti-D a dosis de 300 mcg (1.500 UI) por vía intramuscular a las 28 semanas de gestación. Esta dosis antenatal previene la sensibilización materna que puede ocurrir por microtransfusiones feto-maternas asintomáticas durante el tercer trimestre. Si el recién nacido resulta ser Rh positivo al nacer, se administrará una segunda dosis dentro de las 72 horas postparto. C) Incorrecta. Esperar solo al postparto deja una ventana de riesgo de sensibilización del 1-2% en el tercer trimestre. D) Incorrecta. La amniocentesis es invasiva y solo se realiza ante sospecha de anemia en sensibilizadas graves. E) Incorrecta. El plasma no aporta anticuerpos anti-D terapéuticos.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: B**

**Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada**

3.01.1.012

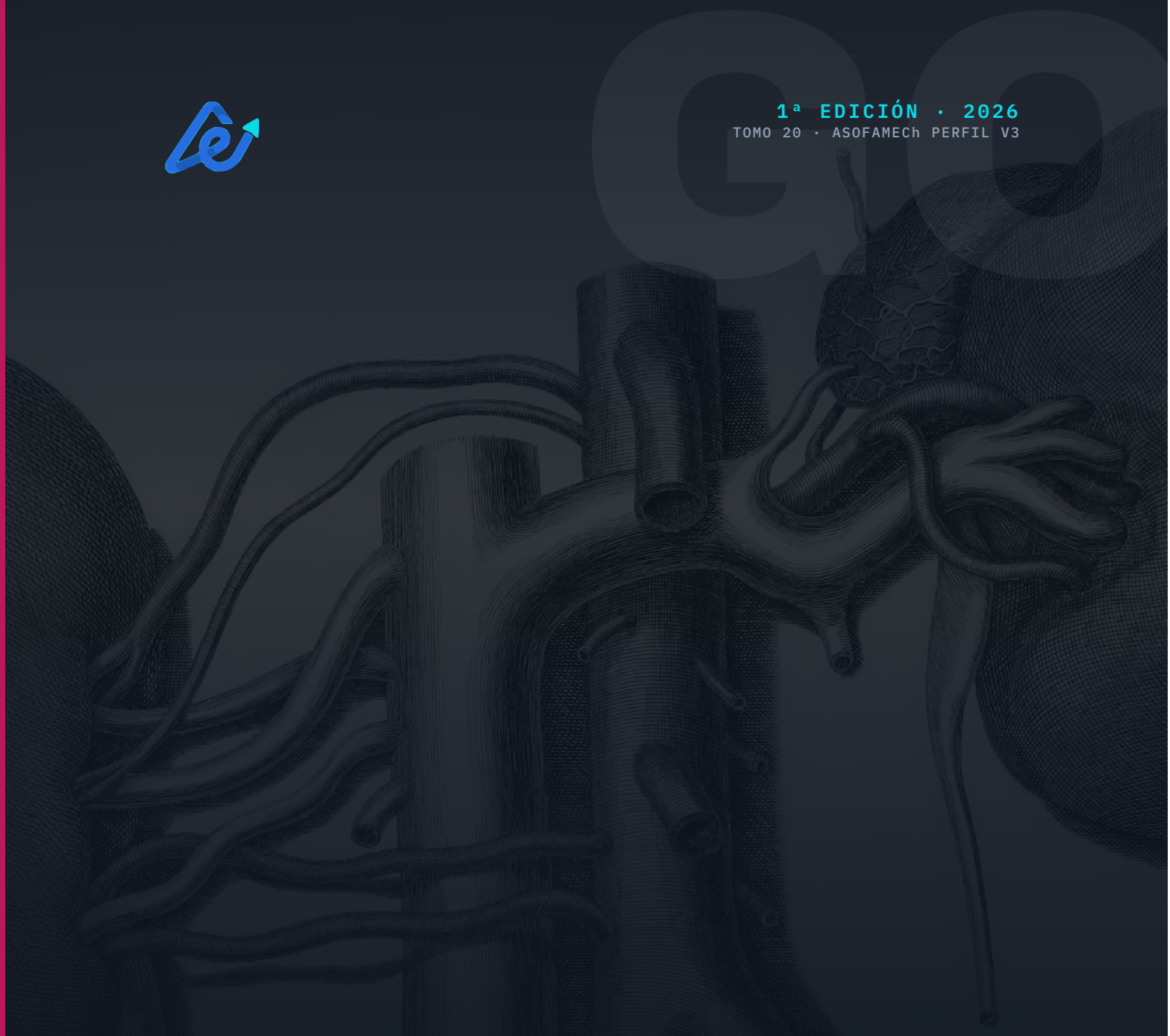
Dx: Específico
· Tx: Completo
· Seg: Completo

GES

A) Incorrecta. La administración de inmunoglobulina anti-D en una mujer ya sensibilizada (Coombs positivo) es totalmente inútil, pues la profilaxis previene la respuesta inmune primaria pero no tiene ningún efecto sobre los linfocitos B de memoria ya activados ni sobre los anticuerpos preexistentes. B) Correcta. La paciente es una gestante Rh (-) SENSIBILIZADA con títulos de anticuerpos de 1:64, muy por encima del título crítico (1:16). Por ende, está formalmente contraindicada la inmunoglobulina anti-D y la paciente debe ser derivada a la Unidad de Medicina Materno-Fetal para seguimiento con Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media (ACM) a partir de la semana 18-20 para pesquisar anemia fetal moderada a grave de forma no invasiva. C) Incorrecta. La exanguinotransfusión materna no tiene rol en la aloinmunización. D) Incorrecta. La tasa de supervivencia con transfusión intrauterina supera el 90%. E) Incorrecta. Los anticuerpos de la aloinmunización son de clase IgG y cruzan activamente la placenta.

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 20 · ASOFAMECh PERFIL V3



MÓDULO 3

# GINECOLOGÍA

## 90 Preguntas de Práctica

Oncología Ginecológica

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Ginecología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA** | | | | | |
| 3.01.1.012 | Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3 | Tomo 19 · 19.20 (Pág. 72) |
| 3.01.1.014 | Dolor pelviano y dismenorrea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.018 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.021 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.023 | Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.027 | Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.018 | Pelviperitonitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.001 | Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 20 · 20.1 (Pág. 5) |
| 3.02.1.002 | Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q9, Q10 | Tomo 20 · 20.2 (Pág. 9) |
| 3.02.1.003 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 20 · 20.3 (Pág. 11) |
| 3.02.1.004 | Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 20 · 20.4 (Pág. 15) |
| **BLOQUE 2: ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN** | | | | | |
| 3.01.1.015 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q23, Q24 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.017 | Enfermedades de transmisión sexual | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.1.020 | Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.026 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.032 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q31 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.016 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.020 | Mastitis abscedada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q20 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.005 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 20 · 20.5 (Pág. 20) |
| 3.02.1.006 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33 | Tomo 20 · 20.6 (Pág. 24) |
| 3.02.1.007 | Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 20 · 20.7 (Pág. 26) |
| **BLOQUE 3: ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN** | | | | | |
| 3.01.1.019 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30) |
| 3.01.1.022 | Oligoanovulación crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.002 | Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.008 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.008 | Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q41, Q42, Q43, Q44 | Tomo 20 · 20.8 (Pág. 28) |
| 3.02.1.009 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 20 · 20.9 (Pág. 35) |
| 3.02.1.010 | Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40 | Tomo 20 · 20.10 (Pág. 39) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 4: INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO** | | | | | |
| 3.01.1.013 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.016 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65, Q66, Q67 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.025 | Proceso inflamatorio pelviano | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.030 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.011 | Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59 | Tomo 20 · 20.11 (Pág. 41) |
| 3.02.1.012 | Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q60, Q61 | Tomo 20 · 20.12 (Pág. 45) |
| 3.02.1.013 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 20 · 20.13 (Pág. 50) |
| **BLOQUE 5: ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA** | | | | | |
| 3.01.1.024 | Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.028 | Tumores ováricos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.029 | Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q74 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.019 | Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.014 | Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78 | Tomo 20 · 20.14 (Pág. 54) |
| 3.02.1.015 | Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q84, Q85, Q86, Q87 | Tomo 20 · 20.15 (Pág. 58) |
| 3.02.1.016 | Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 20 · 20.16 (Pág. 62) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Ginecología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)



| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01.1.012 | Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q3 | Tomo 19 · 19.20 (Pág. 72) |
| 3.01.1.013 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.014 | Dolor pelviano y dismenorrea | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.015 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21, Q22, Q23, Q24 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.016 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q65, Q66, Q67 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.017 | Enfermedades de transmisión sexual | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.018 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q11 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.019 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | GES | Q45, Q46, Q47, Q48, Q49 | Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30) |
| 3.01.1.020 | Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q34 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.021 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.022 | Oligoanovulación crónica | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | — | Q37 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.023 | Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q17 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.024 | Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q79, Q80, Q81, Q82, Q83 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.025 | Proceso inflamatorio pelviano | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.026 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | GES | Q30 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | **Derivar** | | | |
| 3.01.1.027 | Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.028 | Tumores ováricos | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.029 | Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q74 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.030 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q68 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.1.032 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q31 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.002 | Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q38 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.008 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q50 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.016 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.018 | Pelviperitonitis | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.019 | Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q88 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.01.2.020 | Mastitis abscedada | Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere** | — | Q20 | Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8) |
| 3.02.1.001 | Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q4, Q5, Q6, Q7 | Tomo 20 · 20.1 (Pág. 5) |
| 3.02.1.002 | Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q9, Q10 | Tomo 20 · 20.2 (Pág. 9) |
| 3.02.1.003 | Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q13, Q14, Q15, Q16 | Tomo 20 · 20.3 (Pág. 11) |
| 3.02.1.004 | Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q18 | Tomo 20 · 20.4 (Pág. 15) |
| 3.02.1.005 | Endometriosis y Adenomiosis: Tríada | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · | GES | Q26, Q27, Q28, Q29 | Tomo 20 · 20.5 (Pág. 20) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado | Seg: **Completo** | | | |
| 3.02.1.006 | Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q32, Q33 | Tomo 20 · 20.6 (Pág. 24) |
| 3.02.1.007 | Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q35, Q36 | Tomo 20 · 20.7 (Pág. 26) |
| 3.02.1.008 | Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q41, Q42, Q43, Q44 | Tomo 20 · 20.8 (Pág. 28) |
| 3.02.1.009 | Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q51, Q52, Q53, Q54 | Tomo 20 · 20.9 (Pág. 35) |
| 3.02.1.010 | Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q39, Q40 | Tomo 20 · 20.10 (Pág. 39) |
| 3.02.1.011 | Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59 | Tomo 20 · 20.11 (Pág. 41) |
| 3.02.1.012 | Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q60, Q61 | Tomo 20 · 20.12 (Pág. 45) |
| 3.02.1.013 | Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 20 · 20.13 (Pág. 50) |
| 3.02.1.014 | Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q75, Q76, Q77, Q78 | Tomo 20 · 20.14 (Pág. 54) |
| 3.02.1.015 | Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo** | GES | Q84, Q85, Q86, Q87 | Tomo 20 · 20.15 (Pág. 58) |
| 3.02.1.016 | Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico | Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo** | GES | Q89, Q90 | Tomo 20 · 20.16 (Pág. 62) |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA

PREGUNTA 1 3.01.1.014

**1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Dolor pelviano y dismenorrea · 3.01.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Dolor pelviano y dismenorrea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2 3.01.2.018

**2. Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es sexualmente ac8va y u8liza disposi8vo intrauterino 8po T de cobre como método an8concep8vo. Refiere que el dolor es más intenso en el abdomen bajo, mayor al lado derecho. En su examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 108 por minuto y presión arterial 110/70 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación abdominal baja y signo de Blumberg esbozado a derecha. La especuloscopía muestra cuello uterino con secreción purulenta y el tacto vaginal demuestra dolor a la presión cervical y a la palpación de ambos anexos, mayor a derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Embarazo ectópico
B) Aborto sép2co
C) Torsión ovárica
D) Pelviperitoni2s
E) Apendici2s aguda

PREGUNTA 3 3.01.1.012

**3. Una paciente de 38 años, multípara de 4, con antecedente de 5 abortos, que requirieron de legrado, nota disminución progresiva del flujo menstrual, hasta haber caído en amenorrea, desde hace 100 días. Su examen físico no muestra alteraciones y no utiliza métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Asherman
B) Menopausia precoz
C) Hiperprolactinemia
D) Síndrome de ovario poliquístico
E) Hipopituitarismo

PREGUNTA 4 3.02.1.001

**4. Una paciente de 25 años, con antecedentes de menstruaciones regulares, consulta por amenorrea de 5 meses. No utiliza métodos anticonceptivos hormonales. La prueba de β-hCG en orina resulta negativa. El médico administra Medroxiprogesterona 10 mg al día por vía oral durante 10 días, presentando la paciente un sangrado genital abundante de características menstruales 3 días después de suspender el fármaco (Test de Progesterona positivo). ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica de este resultado?**

A) Falla ovárica prematura con agotamiento folicular irreversible
B) Presencia de un endometrio adecuadamente proliferado por estrógenos endógenos pero con anovulación
C) Estenosis cervical obstructiva secundaria con retención hemática intrauterina
D) Síndrome de Asherman con sinequias uterinas completas
E) Hipogonadismo hipogonadotropo por tumor selar destructor

PREGUNTA 5 3.02.1.001

**5. Una joven de 17 años es evaluada por amenorrea primaria. Al examen físico presenta una talla de 1.70 m, excelente desarrollo mamario Tanner V, pero llama la atención la ausencia casi completa de vello axilar y pubiano (Tanner I). Al examen ginecológico se constata una vagina ciega de 3 cm de profundidad, sin palparse cuello uterino ni útero en la ecografía pelviana. En ambos conductos inguinales se palpan masas móviles no dolorosas. El estudio citogenético informa un cariotipo 46,XY. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
B) Síndrome de Turner
C) Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (Síndrome de Morris)
D) Disgenesia gonadal pura (Síndrome de Swyer)
E) Hiperplasia suprarrenal congénita clásica

PREGUNTA 6 3.02.1.001

**6. Una paciente de 33 años, con antecedente de legrado uterino instrumental por aborto incompleto hace 6 meses, consulta por ausencia de menstruación desde el procedimiento. La β-hCG es negativa, TSH y prolactina normales. Se realiza un test de progesterona que resulta negativo. Posteriormente se administra una prueba combinada de estrógenos más progesterona por 21 días, no presentándose sangrado de deprivación. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico sospechado?**

A) Resonancia magnética de hipófisis
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Cariotipo en sangre periférica
D) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E) Medición seriada de hormona antimülleriana

PREGUNTA 7 3.02.1.001

**7. Una mujer de 19 años es evaluada por amenorrea primaria y ausencia total de desarrollo puberal (Tanner mamario I). Durante la anamnesis refiere que desde niña no es capaz de percibir los olores (anosmia). Al laboratorio se encuentra FSH de 0.8 mUI/mL y LH de 0.5 mUI/mL (ambas muy disminuidas). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Turner
B) Síndrome de Kallmann
C) Craneofaringioma
D) Insuficiencia ovárica prematura
E) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

PREGUNTA 8 3.01.1.027

**8. Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultades para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de los síntomas de esta paciente?**

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

PREGUNTA 9 3.02.1.002

**9. Una mujer de 22 años consulta por ciclos menstruales que se presentan cada 50 a 70 días, asociados a aumento de vello facial en mentón y patillas. En la ecografía ginecológica transvaginal se aprecian ambos ovarios con 24 microfolículos periféricos de 3 a 7 mm y un volumen ovárico de 13 mL cada uno. La paciente no desea embarazo en este momento. Además de recomendar cambios en el estilo de vida y baja de peso, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno
B) Anticonceptivos orales combinados con progestágeno antiandrogénico (ej. Etinilestradiol con Dienogest o Ciproterona)
C) Dexametasona oral a altas dosis de por vida
D) Resección ovárica en cuña por laparoscopía
E) Danazol oral continuo

PREGUNTA 10 3.02.1.002

**10. ¿Cuál es la complicación neoplásica ginecológica a largo plazo cuya incidencia se encuentra significativamente aumentada en mujeres jóvenes con Síndrome de Ovario Poliquístico y anovulación crónica que no reciben tratamiento hormonal progestativo periódico?**

A) Cáncer de cuello uterino por virus del papiloma humano
B) Carcinoma de endometrio tipo I (endometrioide)
C) Cáncer epitelial seroso de ovario de alto grado
D) Coriocarcinoma gestacional persistente
E) Sarcoma del estroma endometrial

PREGUNTA 11 3.01.1.018

**11. Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco es normal y su test de embarazo en orina es negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Histerectomía
B) Ácido tranexámico endovenoso
C) Estrógenos inyectables
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Biopsia de endometrio

PREGUNTA 12 3.01.1.021

**12. Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Anticonceptivos orales
B) Agonistas de las gonadotrofinas
C) Histerectomía
D) Miomectomía
E) Observación

PREGUNTA 13 3.02.1.003

**13. Una paciente de 47 años consulta por sangrado uterino anormal de 4 meses de evolución, con menstruaciones abundantes y sangrados intermenstruales ocasionales. Al examen físico no se palpan masas pelvianas y la especuloscopía muestra cuello uterino macroscópicamente sano. La ecografía transvaginal informa útero de dimensiones normales y endometrio de 12 mm de grosor sin miomas ni pólipos identificables. ¿Cuál es la conducta médica de primera línea más adecuada antes de iniciar cualquier terapia hormonal?**

A) Instalación inmediata de un DIU liberador de levonorgestrel sin estudios adicionales
B) Realización de una biopsia de endometrio ambulatoria con cánula de Pipelle
C) Histerectomía total abdominal profiláctica
D) Prescripción de ácido tranexámico oral y alta sin seguimiento
E) Observación durante 6 meses con calendario menstrual

PREGUNTA 14 3.02.1.003

**14.** **Una adolescente de 14 años es traída a la urgencia por metrorragia abundante de 10 días de evolución desde su menarquia hace 4 meses, asociando astenia y palidez. No tiene antecedentes de actividad sexual. El hemograma muestra hemoglobina de 8.0 g/dL. En la anamnesis remota la madre refiere que la niña siempre ha presentado epistaxis frecuentes y equimosis fáciles ante traumatismos mínimos. ¿Cuál es la sospecha etiológica de causa no estructural (clasificación FIGO) más probable?**

A) Adenomiosis uterina difusa
B) Coagulopatía congénita (Enfermedad de von Willebrand)
C) Adenocarcinoma de células claras de endometrio
D) Pólipo endometrial gigante
E) Leiomioma submucoso pediculado

PREGUNTA 15 3.02.1.003

**15.** **¿Cuál de los siguientes métodos terapéuticos médicos ha demostrado la mayor tasa de reducción del volumen de sangrado menstrual (superior al 90% a los 6 meses) y constituye el tratamiento médico de elección para el sangrado uterino anormal de causa endometrial o disovulatoria?**

A) Ácido acetilsalicílico oral en dosis bajas
B) Dispositivo intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG)
C) Dispositivo intrauterino de Cobre (T de Cobre)
D) Anticonceptivos orales de solo progestágeno en dosis intermitentes
E) Vitamina K intramuscular semanal

PREGUNTA 16 3.02.1.003

**16.** **Una paciente de 56 años, menopáusica desde hace 5 años sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un episodio de sangrado vaginal rojo oscuro de 3 días de evolución. La especuloscopía descarta lesiones en cérvix y vagina. La ecografía transvaginal revela un endometrio engrosado de 9 mm, heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial prioritario que debe descartarse y la conducta obligatoria?**

A) Descartar Cáncer de Endometrio mediante Biopsia Endometrial (Pipelle o histeroscópica)
B) Tratar como vaginitis atrófica con óvulos de estriol sin necesidad de biopsia
C) Indicar progestágenos orales por 10 días y reevaluar ecográficamente en 1 año
D) Indicar reposo en cama y control en APS si no repite el sangrado
E) Realizar laparoscopía exploradora de urgencia para ooforectomía bilateral

PREGUNTA 17 3.01.1.023

**17.** **Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperplasia endometrial
B) Miomatosis endometrial
C) Atrofia endometrial
D) Pólipo endometrial
E) Cáncer de endometrio

PREGUNTA 18 3.02.1.004

**18.** **Una paciente de 34 años, nuligesta, que desea embarazarse en el corto plazo, consulta por hipermenorrea de 7 meses de evolución. En la ecografía transvaginal e histerosonografía se identifica un leiomioma submucoso único de 3.5 cm de diámetro localizado en la pared anterior con protrusión del 80% hacia la cavidad endometrial (FIGO 1). El resto del miometrio es normal. ¿Cuál es el tratamiento de elección para esta paciente?**

A) Histerectomía total por vía laparoscópica
B) Resección del mioma mediante Miomectomía Histeroscópica
C) Embolización de arterias uterinas bilateral
D) Administración continua de análogos de GnRH durante 5 años
E) Radioterapia pélvica fraccionada

PREGUNTA 19 3.01.1.017

**19. Una paciente de 31 años multípara de uno, cursando un embarazo de 34 semanas, sin patología previa, acude a control, objetivándose lesiones vaginales, que se muestran a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cesárea electiva
B) Aplicación local de podofilino
C) Iniciar aciclovir oral
D) Realizar tocaciones con ácido tricloroacético
E) Inducir el parto en este momento

PREGUNTA 20 3.01.2.020

**20. Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
B) Drenaje por punción
C) Suspender la lactancia materna
D) Frío local y paracetamol
E) Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

PREGUNTA 21 3.01.1.015

**21. Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. Ecografía transvaginal: útero aumentado de tamaño con ecotextura heterogénea, sin miomas definidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Endometriosis
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Mioma uterino intramural
E) Adenomiosis

PREGUNTA 22 3.01.1.015

**22. Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo? a. Histerectomía con preservación de ovarios**

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

PREGUNTA 23 3.01.1.015

**23. Una mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años de evolución, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra un tumor ovárico derecho, de 6,5 cm de diámetro y aspecto quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (VN: < 35 UI/L). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Carcinoma epitelial
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma maduro
D) Disgerminoma ovárico
E) Quiste folicular

PREGUNTA 24 3.01.1.015

**24. Mujer de 18 años consulta por dismenorrea secundaria, intensa, de 6 meses de evolución que ha aumentado progresivamente, por lo que ha tomado AINEs y paracetamol sin respuesta. Su examen Fsico y ginecológico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar an2concep2vos orales
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
C) Realizar laparoscopía diagnós2ca
D) Solicitar TAC de pelvis
E) Realizar histeroscopía

PREGUNTA 25 3.01.2.016

**25. Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor ab- dominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se solicita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en mode- rada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cuerpo lúteo hemorrágico
B) Cuerpo lúteo roto
C) Apendicitis aguda
D) Torsión ovárica
E) Absceso tubo-ovárico

PREGUNTA 26 3.02.1.005

**26. Una paciente de 26 años consulta por dismenorrea secundaria severa que le impide asistir al trabajo durante sus menstruaciones, dispareunia profunda y dispareunia al defecar (disquecia) durante los días de sangrado. Al tacto bimanual se palpa el útero en retroversoflexión fija con gran sensibilidad en los ligamentos uterosacros. La ecografía ginecológica muestra un quiste ovárico derecho de 3.5 cm con ecos internos homogéneos de bajo nivel en 'vidrio esmerilado'. La paciente no desea embarazo en la actualidad. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico oral de primera línea de elección para el control de sus síntomas dolorosos?**

A) Paracetamol 500 mg cada 12 horas solo durante el sangrado
B) Dienogest 2 mg al día por vía oral de forma continua
C) Metotrexato intramuscular a dosis única
D) Citrato de Clomifeno oral por 5 días cada mes
E) Terapia de reemplazo hormonal con estrógenos equinos solos

PREGUNTA 27 3.02.1.005

**27. Una mujer de 30 años, con antecedente de dolor pélvico crónico e infertilidad primaria de 2 años, se somete a una ecografía transvaginal que revela un quiste ovárico de 5 cm de diámetro de pared delgada, regular, con ecogenicidad interna difusa y homogénea de bajo nivel ('aspecto en vidrio esmerilado'), sin flujo Doppler al interior y sin excrecencias papilares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta lesión ovárica?**

A) Cistoadenocarcinoma seroso de ovario
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma quístico maduro (quiste dermoide)
D) Quiste folicular simple funcional
E) Absceso tubo-ovárico roto

PREGUNTA 28 3.02.1.005

**28. ¿Por qué razón farmacológica el tratamiento médico hormonal con anticonceptivos orales combinados o progestágenos continuos NO está indicado como tratamiento de la infertilidad en una paciente con endometriosis que busca activamente un embarazo?**

A) Porque son teratogénicos irreversibles para cualquier ovocito futuro
B) Porque suprimen la ovulación y no mejoran las tasas de fertilidad ni de nacidos vivos tras suspenderlos, retrasando el tratamiento reproductivo efectivo
C) Porque causan oclusión tubárica bilateral irreversible por fibrosis miometrial
D) Porque aumentan la incidencia de embarazo molar recurrente
E) Porque aceleran la apoptosis de la reserva folicular ovárica

PREGUNTA 29 3.02.1.005

**29. Una paciente de 42 años, multípara de 3, consulta por hipermenorrea severa y dismenorrea secundaria progresiva. Al examen físico se palpa un útero aumentado de tamaño difusamente de 11 semanas, simétrico, reblandecido y difusamente doloroso al tacto bimanual. La ecografía transvaginal muestra engrosamiento asimétrico del miometrio posterior con estriaciones lineales y microquistes miometriales. La biopsia endometrial es benigna. Tras fallar el tratamiento médico, se decide una histerectomía total. ¿Qué hallazgo anatomopatológico confirmará el diagnóstico definitivo?**

A) Glándulas y estroma endometrial ectópicos en el espesor del miometrio con hipertrofia muscular concéntrica (Adenomiosis)
B) Proliferación clonal de células fusiformes de músculo liso miometrial (Leiomioma)
C) Infiltración estromal por células mesenquimatosas malignas con atipias (Leiomiosarcoma)
D) Pólipo vascular fibroepitelial endocervical
E) Tejido decidual ectópico confinado exclusivamente a la serosa peritoneal

PREGUNTA 30 3.01.1.026

**30. Una paciente de 58 años, multípara de cuatro, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina, al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar oxibutinina oral
B) Realizar prueba Q-TIP
C) Realizar pelvic organ prolapse quantification (POP-Q)
D) Solicitar resonancia magnética pelviana
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 31 3.01.1.032

**31. Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A) Oxibutinina
B) Suspensión uretral
C) Terapia de remplazo hormonal
D) Kinesioterapia pélvica
E) Doxasozina

PREGUNTA 32 3.02.1.006

**32. Una paciente de 62 años consulta por sensación de peso genital y escapes de orina involuntarios que ocurren exclusivamente cuando estornuda, tose o levanta objetos pesados. No presenta nicturia ni deseos miccionales apremiantes. Al examen físico se evidencia salida de orina sincrónica con la maniobra de Valsalva y un prolapso de la pared vaginal anterior cuyo punto de mayor descenso se sitúa a 2 cm por fuera del anillo himenal (+2 cm, Estadio III). Tras fracasar la kinesioterapia de piso pélvico, se programa cirugía. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver la incontinencia urinaria de esfuerzo?**

A) Colocación de cabestrillo mediouretral libre de tensión (cinta TOT o TVT)
B) Inyección intravesical de toxina botulínica en el músculo detrusor
C) Prescripción oral de oxibutinina a dosis altas
D) Cistoplastía de aumento con parche intestinal
E) Denervación quirúrgica de los plexos hipogástricos inferiores

PREGUNTA 33 3.02.1.006

**33. Una mujer de 68 años acude a control refiriendo que con frecuencia experimenta una sensación urgente, súbita e incontenible de orinar, no alcanzando a llegar al baño y perdiendo abundantes volúmenes de orina. Además, orina 12 veces al día y se despierta 3 a 4 veces por noche para miccionar. El examen físico y el sedimento de orina son normales. ¿Cuál de las siguientes conductas terapéuticas es la más apropiada?**

A) Indicar colocación de cabestrillo suburetral transobturador (TOT)
B) Iniciar reeducación vesical combinada con un fármaco anticolinérgico como Solifenacina o un agonista beta-3 como Mirabegrón
C) Indicar restricción total de líquidos a menos de 500 mL al día
D) Realizar uretrotomía interna bajo anestesia
E) Indicar tratamiento antibiótico empírico continuo con ciprofloxacino por 6 meses

PREGUNTA 34 3.01.1.020

**34. Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:**

A) Repetir espermiograma
B) Test post coital
C) Laparoscopía
D) Histeroscopía
E) Histerosalpingografía

PREGUNTA 35 3.02.1.007

**35.** **Una pareja acude a consulta por no lograr embarazo tras 2 años de búsqueda. En el estudio básico inicial se realiza una Histerosalpingografía a la mujer, informándose obstrucción tubárica bilateral con hidrosálpinx bilateral y prueba de Cotte negativa. El espermiograma del cónyuge y la reserva ovárica de la mujer son normales. ¿Cuál es el tratamiento de fertilidad más adecuado que debe indicarse?**

A) Inseminación intrauterina con semen de donante
B) Inducción de ovulación con Citrato de Clomifeno y relaciones sexuales programadas
C) Fertilización In Vitro (FIV)
D) Inseminación intrauterina con semen del cónyuge capacitado
E) Antibioticoterapia continua con Doxiciclina durante 6 meses

PREGUNTA 36 3.02.1.007

**36.** **En el estudio de un varón de 30 años cuya pareja no logra concebir, se solicita un espermiograma de control. Para que los resultados del análisis seminal según los estándares internacionales de la OMS sean válidos y confiables, ¿cuántos días de abstinencia sexual previa debe cumplir el paciente antes de recolectar la muestra?**

A) Menos de 24 horas de abstinencia
B) De 3 a 5 días de abstinencia estricta
C) Al menos 20 a 30 días de abstinencia
D) La abstinencia sexual previa es irrelevante para el espermiograma
E) Exactamente 14 días coincidiendo con el ciclo de la pareja

## BLOQUE 3 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN

PREGUNTA 37 3.01.1.022

**37.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Oligoanovulación crónica · 3.01.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Oligoanovulación crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 3.01.2.002

**38.** **Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48 horas de evolución. Sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?**

A) Hematoma vulvar: compresas frías y analgesia si no aumenta
B) Absceso vulvar: drenaje + antibióticos
C) Quiste de Bartolino: observación ambulatoria
D) Linfocele: punción aspirativa
E) Tromboflebitis pélvica: anticoagulación

PREGUNTA 39 3.02.1.010

**39.** **Una paciente de 31 años consulta por dolor vulvar progresivo e invalidante que le impide sentarse. Al examen ginecológico se aprecia una masa de 5 cm de diámetro en el labio mayor izquierdo, en posición de las 4 horas del reloj, caliente, fluctuante, muy eritematosa y de extrema sensibilidad al tacto. Se diagnostica un absceso de la glándula de Bartolino. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico de elección para resolver el cuadro y prevenir la recidiva?**

A) Punción evacuadora con aguja fina bajo anestesia local
B) Incisión, drenaje y marsupialización de la glándula (o colocación de catéter de Word)
C) Vulvectomía simple izquierda
D) Prescripción exclusiva de antibióticos orales sin drenar el absceso
E) Cauterización química con nitrato de plata de la mucosa vestibular

PREGUNTA 40 3.02.1.010

**40.** **Una mujer de 64 años consulta por prurito vulvar intenso y constante de más de 8 meses de evolución que le interrumpe el sueño. Al examen físico se aprecia atrofia severa de los labios menores con enterramiento parcial del clítoris y placas blanquecinas nacaradas adelgazadas de aspecto en papel apergaminado distribuidas en la vulva y región perianal en 'figura de ocho', sin úlceras activas. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco tópico de primera línea de elección?**

A) Candidiasis vulvovaginal crónica; Clotrimazol en crema al 1%
B) Liquen Escleroso Vulvar; Propionato de Clobetasol al 0.05% en ungüento tópico
C) Condilomas acuminados gigantes; Imiquimod al 5% en crema
D) Herpes genital recurrente; Aciclovir tópico en crema
E) Psoriasis invertida; Ácido salicílico al 10%

PREGUNTA 41 3.02.1.008

**41. Una paciente de 36 años, sin antecedentes cardiovasculares pero fumadora activa de una cajetilla diaria (20 cigarrillos al día), solicita inicio de método anticonceptivo. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO (Categoría 4 de la OMS) en esta paciente?**

A) Dispositivo intrauterino de cobre (T de Cobre)
B) Implante subdérmico liberador de etonogestrel
C) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol con levonorgestrel
D) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel
E) Minipíldora oral de desogestrel

PREGUNTA 42 3.02.1.008

**42. Una joven de 20 años consulta en el servicio de urgencia 18 horas después de una relación sexual no protegida por rotura del condón. Solicita la píldora de anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es el fármaco de elección, la dosis recomendada y el mecanismo de acción de la píldora de anticoncepción de emergencia disponible en el sistema público chileno?**

A) Mifepristona 200 mg oral; desprendimiento del blastocisto implantado
B) Levonorgestrel 1.5 mg oral en dosis única; retraso o inhibición del pico ovulatorio de LH
C) Misoprostol 800 mcg vaginal; inducción de contracciones uterinas expulsivas
D) Metotrexato 50 mg intramuscular; lisis de las células trofoblásticas
E) Estrógenos conjugados a altas dosis; inducción de hemorragia masiva

PREGUNTA 43 3.02.1.008

**43. Una paciente de 28 años con antecedente de migraña clásica con aura visual (escotomas centelleantes) frecuente acude a solicitar anticoncepción hormonal. Al evaluar las alternativas, ¿cuál de los siguientes métodos está formalmente contraindicado por clasificarse como Categoría 4 de la OMS?**

A) Anillo vaginal liberador de etinilestradiol y etonogestrel
B) Implante subdérmico de etonogestrel
C) Dispositivo intrauterino de cobre
D) Minipíldora de desogestrel
E) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

PREGUNTA 44 3.02.1.008

**44. Una paciente que tomó la píldora de anticoncepción de emergencia de levonorgestrel 1.5 mg presenta un episodio de vómito profuso 45 minutos después de haber deglutido el comprimido. ¿Cuál es la indicación médica correcta a seguir?**

A) No realizar ninguna acción, pues la absorción intestinal completa ocurre en los primeros 15 minutos
B) Repetir de inmediato la dosis completa de 1.5 mg de Levonorgestrel, idealmente asociando un antiemético oral
C) Indicar que el método fracasó y que debe programarse una interrupción legal del embarazo
D) Administrar antibióticos profilácticos para evitar infecciones
E) Esperar 1 semana y realizar un test de embarazo en sangre

PREGUNTA 45 3.01.1.019

**45. Mujer de 28 años con dispareunia (dolor a la penetración), flujo vaginal gris homogéneo con mal olor (peor post coito) y pH vaginal 5.5. Test de aminas positivo (KOH). ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A) Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días
B) Candidiasis vaginal: fluconazol oral 150 mg dosis única
C) Tricomoniasis: metronidazol 2 g dosis única
D) Herpes genital: aciclovir
E) Cervicitis por clamidia: azitromicina

PREGUNTA 46 3.01.1.019

**46. Una paciente de 31 años de edad refiere mal olor genital, asociado a flujo, que empeora cuando tiene relaciones sexuales. Es usuaria de dispositivo intrauterino de cobre, desde hace 4 años. No tiene PAP vigente, por lo que se solicita un nuevo PAP, que resulta normal. En la especuloscopía se observa leucorrea de color gris, sin lesiones cervicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Retirar el DIU bajo cobertura antibiótica
B) Solicitar cultivo de secreción vaginal
C) Indicar clindamicina tópica en óvulos
D) Indicar clotrimazol tópico en óvulos
E) Indicar fluconazol oral

PREGUNTA 47 3.01.1.019

**47. Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica
B) Indicar fluconazol vía oral
C) Iniciar doxiciclina vía oral
D) Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.
E) Indicar metronidazol por vía oral

PREGUNTA 48 3.01.1.019

**48. Embarazada de 20 semanas con urocultivo positivo para E. coli sensible. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la infección urinaria en el embarazo?**

A) Cefalexina oral por 7 días
B) Amoxicilina oral
C) Cotrimoxazol (contraindicado en tercer trimestre)
D) Ciprofloxacino (contraindicado en embarazo)
E) Nitrofurantoína (evitar en tercer trimestre)

PREGUNTA 49 3.01.1.019

**49. Una paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen físico se aprecia liquenificación y signos de grataje a nivel vulvar, a la especuloscopía se aprecia leucorrea blanquecina. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:**

A) Metronidazol
B) Fluconazol
C) Miconazol
D) Doxiciclina
E) Ceftriaxona

PREGUNTA 50 3.01.2.008

**50.** **Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa con hipotensión 90/60 mmHg y FC 118 lpm. ¿Cuál es el manejo inmediato?**

A) Estabilización hemodinámica + histerectomía de urgencia
B) Ácido tranexámico EV y observar
C) Progestágenos EV en dosis alta
D) Embolización uterina electiva
E) Solo transfusión de GR y alta

PREGUNTA 51 3.02.1.009

**51.** **Una paciente de 25 años acude por flujo vaginal abundante con olor fétido a pescado, que se acentúa después de las relaciones sexuales y de la menstruación. No refiere prurito ni dolor. Al examen con espéculo se observa una secreción homogénea, fluida, de color blanco-grisáceo que recubre la vagina. El pH vaginal es de 5.2. Al agregar una gota de KOH al 10% a la muestra de flujo se desprende un intenso olor a aminas (Whiff test positivo). Al examen microscópico en fresco se aprecian células epiteliales con bordes citoplasmáticos borrosos cubiertos de bacterias ('clue cells'). ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección?**

A) Fluconazol 150 mg oral en dosis única a la paciente y a su pareja
B) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días a la paciente
C) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única
D) Nistatina en crema tópica vulvar por 14 días
E) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días a ambos cónyuges

PREGUNTA 52 3.02.1.009

**52.** **Una mujer de 29 años en tratamiento con amoxicilina por una sinusitis acude a consulta por prurito vulvar desesperante y sensación de ardor al orinar de 3 días de evolución. Al examen físico se evidencia marcado eritema y edema vulvar con fisuras por rascado, y al colocar el espéculo se aprecia una leucorrea blanca espesa en grumos, similar a 'leche cortada', intensamente adherida a las paredes vaginales. El pH vaginal es de 4.0 y el test de aminas con KOH al 10% resulta negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis
B) Candidiasis vulvovaginal
C) Tricomoniasis vaginal sintomática
D) Cervicitis mucopurulenta por Chlamydia trachomatis
E) Vaginitis atrófica senil

PREGUNTA 53 3.02.1.009

**53.** **¿En cuál de las siguientes infecciones ginecológicas del tracto genital inferior es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO prescribir tratamiento farmacológico simultáneo a todas las parejas sexuales de la paciente para evitar la reinfección y cortar la cadena de transmisión epidemiológica?**

A) Vaginosis bacteriana recurrente
B) Candidiasis vulvovaginal esporádica
C) Tricomoniasis vaginal
D) Vaginitis inflamatoria descamativa
E) Infección urinaria baja por Escherichia coli

PREGUNTA 54 3.02.1.009

**54.** **Una paciente de 21 años consulta por leucorrea purulenta y sangrado postcoital ocasional. A la especuloscopía se observa salida de secreción mucopurulenta espesa por el orificio cervical externo y cuello uterino marcadamente friable que sangra con facilidad al pasar la tórula. La paciente se encuentra afebril y sin dolor a la palpación uterina ni anexial. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico recomendado por las guías del MINSAL mientras se esperan los resultados microbiológicos?**

A) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 días oral exclusivamente
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas oral por 10 días
D) Fluconazol 150 mg oral en dosis única
E) Clotrimazol en crema vaginal por 3 noches

## BLOQUE 4 INFECCIONES GINECOLÓGICAS, PATOLOGÍA VULVAR & CLIMATERIO

PREGUNTA 55 3.01.1.025

**55.** **Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico
B) Realizar cultivo endocervical
C) Indicar anticonceptivos orales
D) Iniciar tratamiento antibiótico
E) Realizar laparotomía exploradora

PREGUNTA 56 3.02.1.011

**56. Una joven de 20 años acude por dolor en hipogastrio de 3 días de evolución y secreción vaginal amarillenta. Al examen ginecológico se constata dolor intenso al movilizar el cuello uterino hacia ambos lados (signo de Frenkel positivo) y a la palpación profunda de ambos anexos. La temperatura axilar es de 38.5°C. El test de embarazo en orina es negativo. No se palpan masas pélvicas y no hay signos de irritación peritoneal difusa. La paciente tolera adecuadamente los líquidos orales. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano ambulatorio completo más adecuado según las guías clínicas del MINSAL?**

A) Ciprofloxacino oral 500 mg cada 12 horas por 7 días como monoterapia
B) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas oral por 14 días MÁS Metronidazol 500 mg cada 12 horas oral por 14 días
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
D) Metronidazol 2 g oral en dosis única exclusivamente
E) Gentamicina intramuscular 160 mg dosis única y reposo

PREGUNTA 57 3.02.1.011

**57. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas una paciente con diagnóstico clínico de Enfermedad Pélvica Inflamatoria DEBE ser OBLIGATORIAMENTE HOSPITALIZADA para recibir tratamiento antibiótico parenteral por vía endovenosa?**

A) Paciente de 24 años con EIP leve (Monif I) y buena tolerancia oral
B) Presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) evidenciado en la ecografía transvaginal
C) Paciente con antecedentes de un episodio de EIP hace dos años ya resuelto
D) Paciente con cultivo positivo para Ureaplasma urealyticum en cuello uterino
E) Paciente con pareja sexual que se niega a recibir tratamiento preventivo

PREGUNTA 58 3.02.1.011

**58. Una paciente de 25 años en tratamiento ambulatorio por una EIP consulta en la urgencia por persistencia del dolor pélvico al que se agrega dolor agudo en hipocondrio derecho que empeora con la inspiración profunda, semejante a una pleuresía. La ecografía hepática y biliar descarta colelitiasis y muestra líquido fino perihepático. En la laparoscopía se observan adherencias finas 'en cuerdas de violín' entre la cápsula de Glisson hepática y la pared abdominal anterior. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación?**

A) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatitis por Chlamydia o Gonococo)
B) Hepatitis autoinmune tipo 2
C) Síndrome de Budd-Chiari agudo
D) Absceso hepático amebiano roto
E) Tromboflebitis séptica de la vena porta (Pileflebitis)

PREGUNTA 59 3.02.1.011

**59. Una paciente hospitalizada hace 48 horas por un Absceso Tubo-Ovárico de 8 cm en tratamiento con Clindamicina más Gentamicina endovenosa presenta súbitamente dolor abdominal difuso hiperagudo de intensidad 10/10, palidez profusa, taquicardia de 130 lpm, presión arterial de 80/40 mmHg y abdomen difusamente en tabla con signos de Blumberg y Guéneau de Mussy generalizados. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta médica inmediata que salva la vida de la paciente?**

A) Apendicitis perforada; colonoscopía de urgencia
B) Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Monif IV) con shock séptico; traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora de urgencia
C) Embolia pulmonar; inicio inmediato de anticoagulación con heparina
D) Evolución esperable del ATO; aumentar la dosis de gentamicina y esperar 24 horas
E) Hemorragia digestiva alta; endoscopía digestiva alta

PREGUNTA 60 3.02.1.012

**60. Una paciente de 51 años con antecedentes de histerectomía total por miomatosis hace 3 años consulta por bochornos intensos e insomnio que afectan severamente su calidad de vida tras cesar sus síntomas ováricos hace 1 año. No tiene antecedentes oncológicos personales ni familiares, y su mamografía reciente es normal (BI-RADS 2). ¿Cuál es el esquema de Terapia de Reemplazo Hormonal de elección para esta paciente?**

A) Estrógenos solos en monoterapia (vía oral o transdérmica)
B) Estrógenos combinados con progesterona micronizada continua
C) Progestágenos solos a altas dosis
D) Moduladores selectivos de receptores androgénicos exclusivamente
E) Está formalmente contraindicada cualquier hormona por el antecedente de histerectomía

PREGUNTA 61 3.02.1.012

**61. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas constituye una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para la prescripción de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica en una mujer con síntomas climatéricos?**

A) Antecedente personal tratado de Cáncer de Mama ductal infiltrante
B) Osteoporosis densitométrica con T-score de -2.8
C) Atrofia vulvovaginal sintomática con dispareunia
D) Edad menor a 45 años con menopausia quirúrgica
E) Sofocos moderados en una mujer de 50 años sana

PREGUNTA 62 3.01.1.013

**62. Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:**

A) Colposcopía y biopsia
B) Conización cervical
C) Seguimiento ecográfico
D) Citología cervical
E) Buscar virus papiloma humano

PREGUNTA 63 3.01.1.013

**63. Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como "probable NIE 2", sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopía, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el PAP en este momento
B) Realizar biopsia de cuello uterino
C) Realizar histerectomía radical
D) Realizar un cono cervical
E) Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

PREGUNTA 64 3.01.1.013

**64. Mujer con PAP con NIE III hace 3 años, sin controles, ahora con lesión exofítica ulcerada en cuello uterino. ¿Cuál es la conducta?**

A) Colposcopía y tratamiento inmediato
B) CONO diagnóstico-terapéutico
C) Biopsia cervical
D) Histerectomía total
E) Repetir PAP y controlar en 3 meses

PREGUNTA 65 3.01.1.016

**65. Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopía es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar colposcopía y biopsia cervical
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano
C) Realizar diatermocoagulación cervical
D) Realizar histerectomía
E) Realizar biopsia de endometrio

PREGUNTA 66 3.01.1.016

**66. Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
B) Solicitar nuevo PAP en 6 años
C) Realizar colposcopía y eventual biopsia
D) Realizar conización cervical
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 67 3.01.1.016

**67. Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?**

A) Involución espontánea
B) NIE 2
C) Carcinoma in situ
D) Condiloma acuminado
E) Cáncer de cuello uterino

PREGUNTA 68 3.01.1.030

**68. Una paciente de 58 años consulta por lesiones pruriginosas con descamación en el pezón y la areola derecha de 6 meses de evolución, sin respuesta al tratamiento con an8micó8cos tópicos. Al examen Fsico se observa lo siguiente: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Cáncer inflamatorio de mama
B) Enfermedad de Paget
C) Derma22s de contacto
D) Psoriasis del pezón
E) Mas22s

PREGUNTA 69 3.02.1.013

**69. Una paciente de 38 años recibe el resultado de su Papanicolaou de tamizaje rutinario que informa: 'Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL)'. A la especuloscopía el cuello uterino luce sin lesiones exofíticas evidentes y la paciente está asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta según la normativa GES del MINSAL?**

A) Repetir el PAP en 6 meses para confirmar la persistencia de la lesión
B) Notificar GES y derivar inmediatamente a la Unidad de Patología Cervical (UPC) para Colposcopía y biopsia dirigida
C) Prescribir óvulos vaginales de metronidazol con nistatina por 10 días y dar de alta
D) Programar histerectomía total simple por vía laparoscópica de inmediato
E) Administrar vacuna contra VPH como tratamiento curativo de la lesión

PREGUNTA 70 3.02.1.013

**70. Una paciente de 49 años consulta por sangrado genital postcoital y fetidez vaginal de 3 meses. Al examen ginecológico con espéculo se observa un tumor ulcerado y vegetante de 4 cm en el cuello uterino. Al tacto rectovaginal se palpa que la induración tumoral se extiende y compromete de forma evidente el tercio medial del parametrio izquierdo, sin alcanzar la pared ósea pélvica. La biopsia confirma Carcinoma Epidermoide Invasor de cuello uterino (Estadio IIB de la FIGO). ¿Cuál es el tratamiento de elección indicado?**

A) Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral (Operación de Wertheim-Meigs)
B) Conización cervical con márgenes amplios
C) Quimiorradioterapia concomitante (Radioterapia externa + Braquiterapia + Cisplatino semanal)
D) Histerectomía total simple extrafascial
E) Tratamiento exclusivamente sintomático y cuidados paliativos

PREGUNTA 71 3.02.1.013

**71. ¿Cuál es la edad y la periodicidad del tamizaje poblacional universal garantizado por el régimen GES para la detección precoz del Cáncer Cervicouterino en Chile mediante el examen de Papanicolaou (PAP)?**

A) Anual en todas las mujeres a partir del inicio de la actividad sexual hasta los 80 años
B) Cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años de edad
C) Cada 5 años en mujeres de 50 a 69 años de edad exclusivamente
D) Semestral en mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales orales
E) Única vez en la vida a los 35 años de edad

PREGUNTA 72 3.02.1.013

**72. ¿Cuáles son los dos genotipos oncogénicos del Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo más prevalentes a nivel mundial y en Chile, responsables de más del 70% de los carcinomas invasores de cuello uterino?**

A) VPH tipos 6 y 11
B) VPH tipos 16 y 18
C) VPH tipos 1 y 2
D) VPH tipos 42 y 43
E) VPH tipos 5 y 8

## BLOQUE 5 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA

PREGUNTA 73 3.01.1.028

**73. Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:**

A) Quiste funcional
B) Mioma uterino
C) Cáncer de ovario
D) Cáncer de colon
E) Endometriosis

PREGUNTA 74 3.01.1.029

**74. Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indolora, que no está adherida a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste mamario
B) Fibroadenoma
C) Cáncer de mama
D) Papiloma mamario
E) Tumor filoides

PREGUNTA 75 3.02.1.014

**75. Una paciente de 52 años asintomática se realiza una mamografía de tamizaje rutinario que informa: 'En el cuadrante superoexterno de la mama izquierda se observa un nódulo espiculado de 15 mm con microcalcificaciones heterogéneas agrupadas en su interior, clasificado como BI-RADS 4C'. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de primera línea indicada a continuación?**

A) Control mamográfico estricto a los 6 meses para evaluar estabilidad
B) Realización de Biopsia con aguja gruesa (Core Biopsy) guiada por imágenes
C) Mastectomía radical de urgencia sin confirmación anatomopatológica previa
D) Punción con aguja fina (PAAF) para estudio citológico exclusivo
E) Administración empírica de tamoxifeno oral durante 3 meses

PREGUNTA 76 3.02.1.014

**76. Una mujer de 58 años es sometida a una tumorectomía conservadora de mama con márgenes quirúrgicos libres por un carcinoma ductal infiltrante de 18 mm. ¿Cuál de las siguientes terapias adyuvantes locales es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIA tras una cirugía conservadora de mama para reducir la tasa de recidiva local al mismo nivel que una mastectomía total?**

A) Radioterapia externa sobre la glándula mamaria restante
B) Quimioterapia con metotrexato intratecal
C) Vaciamiento ganglionar axilar radical bilateral
D) Inyecciones locales de interferón alfa intralesional
E) Ninguna, la cirugía conservadora con bordes libres no requiere tratamientos adicionales

PREGUNTA 77 3.02.1.014

**77. Una paciente de 46 años, no lactante, consulta por la salida espontánea de secreción serohemática (líquido rosado con estrías de sangre) por un único poro del pezón de la mama derecha desde hace 3 semanas. A la palpación física no se identifican nódulos dominantes ni adenopatías axilares. ¿Cuál es la causa etiológica benigna más frecuente de este tipo de telorrea?**

A) Fibroadenoma mamario simple
B) Papiloma intraductal solitario
C) Prolactinoma hipofisario
D) Mastitis granulomatosa idiopática
E) Ectasia ductal senil

PREGUNTA 78 3.02.1.014

**78. Una paciente de 42 años diagnosticada de cáncer de mama invasor presenta el siguiente informe de inmunohistoquímica tumoral: Receptores de Estrógeno (RE) negativos (0%), Receptores de Progesterona (RP) negativos (0%) y HER2 negativo (Score 0). ¿A qué subtipo molecular corresponde este tumor y cuál es la implicancia terapéutica respecto a la hormonoterapia y anticuerpos monoclonales anti-HER2?**

A) Subtipo Luminal A; responderá excelentemente a Tamoxifeno como única terapia
B) Subtipo Triple Negativo; NO responderá a hormonoterapia ni a Trastuzumab, requiriendo quimioterapia citotóxica
C) Subtipo HER2 enriquecido; indicación prioritaria de Trastuzumab con Pertuzumab
D) Subtipo Luminal B; requiere monoterapia con inhibidores de aromatasa
E) Carcinoma basocelular de la mama; solo requiere seguimiento sin fármacos

PREGUNTA 79 3.01.1.024

**79. Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Indicar estrógenos tópicos
C) Solicitar colposcopía y biopsia
D) Realizar curejate endocervical
E) Solicitar ecografía transvaginal

PREGUNTA 80 3.01.1.024

**80. Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:**

A) Suspender ACO y controlar en 3 meses
B) Legrado biópsico en pabellón
C) Biopsia aspirativa de forma ambulatoria.
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 81 3.01.1.024

**81. Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Instalar dispositivo intrauterino medicado
C) Disminuir la dosis de tamoxifeno
D) Solicitar biopsia endometrial
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 82 3.01.1.024

**82. Una mujer de 62 años, con antecedente de 2 episodios de metrorragia autolimitada, en los últimos 3 meses, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 10 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
C) Solicitar resonancia magnética de pelvis
D) Realizar biopsia endometrial
E) Observar evolución

PREGUNTA 83 3.01.1.024

**83. Postmenopáusica con metrorragia y endometrio de 18 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ecografía transvaginal en 3 meses
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Legrado uterino bajo anestesia
D) Iniciar gestágenos y controlar
E) Solicitar biopsia endometrial

PREGUNTA 84 3.02.1.015

**84. Una paciente de 63 años consulta por sangrado vaginal rojo oscuro escaso de 2 semanas de evolución tras 12 años de amenorrea menopáusica. La ecografía transvaginal muestra un grosor endometrial de 12 mm, heterogéneo e irregular. ¿Cuál es el paso diagnóstico que debe realizarse de inmediato?**

A) Prescribir óvulos de estriol vaginal durante 1 mes y reevaluar con ecografía
B) Realización de una Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle o histeroscopía)
C) Solicitar tomografía por emisión de positrones (PET-CT) de cuerpo entero
D) Indicar reposo en cama y control ecográfico en 6 meses
E) Realizar laparoscopía exploradora diagnóstica para ooforectomía bilateral

PREGUNTA 85 3.02.1.015

**85. Una mujer de 65 años consulta por distensión abdominal progresiva, dispepsia y saciedad precoz de 3 meses de evolución. Al examen físico se palpa abdomen distendido con matidez desplazable compatible con ascitis y una masa pelviana profunda firme. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial derecha de 9 cm, multiloculada, con septos gruesos de 5 mm, abundantes proyecciones papilares sólidas internas con vascularización Doppler central de baja resistencia, y abundante líquido libre ascítico en fondo de saco de Douglas. El marcador sérico CA-125 resulta en 450 U/mL (VN < 35 U/mL). ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable y la conducta adecuada?**

A) Quiste folicular funcional simple; indicar anticonceptivos orales por 3 meses
B) Cáncer epitelial de ovario avanzado; derivar de inmediato a Ginecología Oncológica para laparotomía etapificadora y citorreducción primaria
C) Punción transvaginal evacuadora del quiste ovárico para aliviar la presión
D) Endometrioma ovárico; prescribir dienogest oral continuo
E) Absceso apendicular crónico; apendicectomía electiva ambulatoria

PREGUNTA 86 3.02.1.015

**86. ¿Por qué razón oncológica fundamental está FORMALMENTE CONTRAINDICADO realizar una punción-aspiración con aguja de una masa anexial ovárica con criterios ecográficos sospechosos de malignidad?**

A) Porque induce una hemorragia digestiva masiva secundaria
B) Porque la rotura de la cápsula quística provoca la siembra y diseminación de células malignas en la cavidad peritoneal, empeorando el estadio y pronóstico oncológico de la paciente
C) Porque eleva de forma irreversible los niveles plasmáticos de CA-125
D) Porque provoca el cierre precoz de las trompas de Falopio contralaterales
E) Porque desencadena una crisis de tirotoxicosis autoinmune

PREGUNTA 87 3.02.1.015

**87. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas se asocia al mayor riesgo relativo de desarrollar un Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I endometrioide debido a la estimulación estrogénica continua no balanceada?**

A) Multiparidad con más de 4 hijos
B) Uso prolongado de anticonceptivos orales combinados durante más de 10 años
C) Obesidad severa (aromatización periférica en tejido adiposo) y Síndrome de Ovario Poliquístico
D) Tabaquismo crónico activo de más de 20 cigarrillos al día
E) Uso continuo de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

PREGUNTA 88 3.01.2.019

**88. Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa iliaca derecha, que se ha asociado a vómitos alimentarios y que inició hace 48 horas. Al examen físico T°: 36°C, FC: 110x', PA: 110/70 mmHg. El examen abdominal muestra resistencia muscular involuntaria a la palpación de la fosa ilíaca derecha, con ruidos hidroaéreos conservados. Se realiza tacto vaginal, que resulta inconcluso debido a resistencia muscular. Se solicita una ecografía ginecológica transvaginal, que visualiza un tumor anexial derecho quístico multiloculado, de 10 cm de diámetro, con ausencia de flujo al Doppler color. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Embarazo ectópico
C) Proceso inflamatorio pélvico
D) Tumor anexial torcido
E) Cáncer de ovario

PREGUNTA 89 3.02.1.016

**89. Una joven de 21 años consulta por dolor intenso y súbito en fosa ilíaca izquierda de 5 horas de evolución que se acompaña de náuseas y múltiples vómitos alimentarios. La prueba de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal Doppler revela un ovario izquierdo aumentado de volumen a 7 cm con estroma marcadamente edematoso y ausencia de flujo vascular al Doppler color, visualizándose el 'signo del remolino' en el pedículo. ¿Cuál es el tratamiento médico-quirúrgico inmediato más adecuado?**

A) Prescribir analgesia con ketorolaco endovenoso y enviar a reposo en domicilio
B) Laparoscopía de urgencia inmediata para detorsión ovárica y preservación del anexo
C) Punción transvaginal evacuadora guiada por ecografía
D) Tratamiento antibiótico endovenoso para enfermedad pélvica inflamatoria
E) Ooforectomía radical izquierda abierta sin desenrollar el ovario

PREGUNTA 90 3.02.1.016

**90. Una paciente de 24 años consulta por dolor pélvico agudo de inicio brusco tras mantener relaciones sexuales coitales hace 3 horas. Se encuentra en el día 23 de su ciclo menstrual (fase lútea tardía). Signos vitales: PA 118/74 mmHg, FC 78 lpm, afebril. Abdomen blando, sensible en fosa ilíaca derecha sin signos peritoneales. La prueba rápida de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal muestra una imagen quística ovárica derecha de 3.5 cm con múltiples septos finos reticulares en 'red de pesca' y escaso líquido libre anecoico en el fondo de saco de Douglas. Su hematocrito es de 40% y se mantiene estable tras 4 horas de observación. ¿Cuál es la conducta médica indicada?**

A) Laparotomía exploradora de urgencia para ooforectomía derecha
B) Manejo médico conservador expectante con analgesia oral, reposo y control ambulatorio
C) Cistectomía ovárica laparoscópica inmediata
D) Inicio de quimioterapia con metotrexato parenteral
E) Transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA, CICLO MENSTRUAL & SUA · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

**Dolor pelviano y dismenorrea**

3.01.1.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Dolor pelviano y dismenorrea" (3.01.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 2 Respuesta: D

**Pelviperitonitis**

3.01.2.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un proceso inflamatorio pélvico (PIP) clásico, también llamado enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o pelviperitoniGs cuando hay signos de compromiso peritoneal. Se debe estudiar con una ecografía TV para descartar abscesos tubo ováricos. Además, se debe tratar con antibióticos de amplio espectro. No es necesario reGrar el DIU, a menos que no responda en 48 horas de antibioterapia o que además del PIP se confirme la presencia de Ac9nomyces.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A

**Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea**

3.01.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Síndrome de Asherman: El caso corresponde a un síndrome de Asherman clásico, también llamado sinequias uterinas, causado por un legrado uterino. En la ecografía transvaginal se suele ver con endometrio fino. Se trata con cirugía.

### PREGUNTA 4 Respuesta: B

**Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea**

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la falla ovárica prematura no hay estrógenos para proliferar el endometrio, por lo que el test de progesterona resulta negativo. B) Correcta. El Test de Progesterona consiste en administrar un progestágeno durante 5 a 10 días para inducir la maduración secretora del endometrio y posterior descamación por deprivación. Si la paciente sangra (Test Positivo), significa con absoluta certeza que su organismo produce cantidades suficientes de Estrógenos endógenos para preparar y proliferar el endometrio, pero no produce progesterona propia debido a la ausencia de cuerpo lúteo, lo que define un estado de Anovulación crónica (la causa más frecuente en mujeres jóvenes es el Síndrome de Ovario Poliquístico). C) Incorrecta. Si hubiera estenosis cervical la sangre no podría exteriorizarse por la vagina. D) Incorrecta. En el síndrome de Asherman no hay endometrio funcionante y el test de progesterona es estrictamente negativo. E) Incorrecta. En el hipogonadismo hipogonadotropo no hay estímulo ovárico ni estrógenos.

### PREGUNTA 5 Respuesta: C

**Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea**

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En el síndrome de Rokitansky el cariotipo es 46,XX y el vello pubiano y axilar es completamente normal. B) Incorrecta. El Turner tiene cariotipo 45,X0, talla baja y mamas no desarrolladas. C) Correcta. El Síndrome de Morris (Feminización Testicular o Insensibilidad a los Andrógenos) es una entidad con cariotipo 46,XY caracterizada por la mutación del receptor de andrógenos. Los testículos fetales producen testosterona y hormona antimülleriana (AMH); la AMH produce regresión de los conductos de Müller (por lo que NO hay útero ni tercio superior de vagina). Debido a la insensibilidad androgénica periférica completa, los genitales externos se desarrollan con fenotipo femenino y NO se desarrolla vello púbico ni axilar (signo patognomónico). La testosterona circulante se aromatiza periféricamente a estrógenos, generando un excelente desarrollo de mamas. Las masas inguinales corresponden a los testículos ectópicos, los cuales deben extirparse tras completar la pubertad por riesgo de neoplasia (gonadoblastoma/seminoma). D) Incorrecta. En Swyer no hay desarrollo mamario (mamas infantiles por falta de estrógenos) y sí tienen útero. E) Incorrecta. Provoca virilización de genitales en fetos 46,XX.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: B**

**Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea**

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La RMN sella se solicita ante hiperprolactinemia, pero aquí el problema es endometrial. B) Correcta. El fracaso en presentar sangrado por deprivación tras el ciclo combinado de estrógenos más progesterona demuestra que el endometrio no responde o existe una obliteración mecánica del canal uterino. En una paciente con antecedente reciente de legrado uterino, este hallazgo es patognomónico del Síndrome de Asherman (sinequias o adherencias intrauterinas cicatriciales que obliteran la cavidad endometrial). El estándar de oro diagnóstico y terapéutico indiscutido es la Histeroscopía, la cual permite visualizar directamente las bridas y realizar la lisis quirúrgica de las mismas. C) Incorrecta. El cariotipo es para amenorreas primarias. D) Incorrecta. La TAC no tiene resolución para sinequias endometriales. E) Incorrecta. La AMH evalúa reserva ovárica, no la cavidad uterina.

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: B**

**Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea**

3.02.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El Turner tiene FSH marcadamente elevada por falla ovárica gonadal, no baja, y no tiene anosmia. B) Correcta. La asociación patognomónica de hipogonadismo hipogonadotropo (FSH y LH muy disminuidas con falta de desarrollo puberal) y Anosmia o Hiposmia congénita define el Síndrome de Kallmann. Se debe a un defecto genético en la migración embrionaria de las neuronas secretoras de GnRH y de las neuronas del bulbo olfatorio desde la placoda olfatoria hacia el hipotálamo. C) Incorrecta. El craneofaringioma produce cefalea, alteraciones del campo visual (hemianopsia) y diabetes insípida, no anosmia congénita aislada. D) Incorrecta. La falla ovárica cursa con FSH elevada. E) Incorrecta. En Rokitansky el eje gonadotropo es normal y las pacientes tienen excelente desarrollo mamario.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

**Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo**

3.01.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene síntomas climatéricos, que se tratan con terapia de reemplazo hormonal. La regla general es que se usan estrógenos más progestágenos, salvo en las pacientes histerectomizadas, en que se usa estrógeno solo. En este caso tiene útero, ya que tiene reglas irregulares. En los casos en que la TRH está contraindicada (ej. cáncer de mama) se usan los antidepresivos, ya sea IRS o venlafaxina. En la práctica, suele indicarse de tipo continua, ya que no sirve mayormente la TRH cíclica (aunque hay quienes postulan que sirve en el inicio de los síntomas climatérico, como una forma de ciclar a la paciente con reglas irregulares; sin embargo, en la práctica casi no existen fármacos de ese tipo disponibles en el medio chileno, salvo que use ACOs como TRH).

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: B**

**Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo**

3.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El clomifeno se utiliza para inducir ovulación en mujeres que desean embarazarse activamente. B) Correcta. La paciente cumple con los tres criterios de Rotterdam para SOP (oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico y morfología ovárica ecográfica policística). En mujeres que no buscan fertilidad, la primera línea farmacológica según las guías internacionales y del MINSAL son los Anticonceptivos Orales Combinados (ACOs) con progestágeno antiandrogénico (Dienogest, Drospirenona o Acetato de Ciproterona). Los ACOs reducen la secreción de LH, elevan la SHBG plasmática (disminuyendo la testosterona libre circulante, lo que mejora el acné y el hirsutismo) y regularizan las descamaciones endometriales, previniendo el desarrollo de hiperplasia endometrial. C) Incorrecta. Los corticoides no son el tratamiento del SOP. D) Incorrecta. La cirugía de resección ovárica está en desuso por riesgo de adherencias pelvianas e insuficiencia ovárica. E) Incorrecta. El danazol es androgénico y empeoraría el hirsutismo.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: B**

**Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo**

3.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El CCU depende de la infección persistente por VPH, no de la anovulación. B) Correcta. En el SOP, la anovulación crónica persistente provoca una ausencia prolongada de cuerpo lúteo y, por ende, de progesterona. Esto genera un ambiente hormonal caracterizado por la presencia continua de estrógenos libres que estimulan de forma ininterrumpida la proliferación celular del endometrio sin la acción maduradora y antiproliferativa de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). Con los años, esta hiperproliferación conduce sucesivamente a hiperplasia endometrial simple, hiperplasia endometrial con atipias y finalmente a Adenocarcinoma de Endometrio de tipo I (endometrioide), con un riesgo de 3 a 5 veces superior al de mujeres ovuladoras. C) Incorrecta. El cáncer epitelial de ovario se relaciona con mayor número de ovulaciones incesantes (el SOP es anovulatorio). D) Incorrecta. Es un tumor trofoblástico postgestacional. E) Incorrecta. Neoplasia mesenquimatosa no vinculada al SOP.

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: E**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.01.1.018 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 5). Evalúa el manejo clínico de Hemorragia genital anormal según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: D**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.01.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: B**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Instalar un DIU-LNG sin descartar previamente malignidad en una mujer de 47 años con endometrio engrosado puede retrasar catastróficamente el diagnóstico de un adenocarcinoma endometrial. B) Correcta. Según los consensos internacionales (FIGO, ACOG) y las directrices del MINSAL, toda mujer de 45 años o más que consulte por Sangrado Uterino Anormal tiene indicación mandatoria de Biopsia Endometrial (mediante cánula de Pipelle ambulatoria o histeroscopía) para descartar cáncer de endometrio o hiperplasia endometrial con atipias antes de definir o iniciar un tratamiento médico hormonal definitivo. C) Incorrecta. La histerectomía es desproporcionada y prematura sin un diagnóstico histopatológico previo. D) Incorrecta. El ácido tranexámico solo controla el síntoma pero no descarta malignidad. E) Incorrecta. Observar en una paciente perimenopáusica con sangrado abundante es negligencia médica.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: B**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La adenomiosis es excepcional en adolescentes y propia de multíparas sobre 35 años. B) Correcta. Dentro de la clasificación PALM-COEIN, la letra 'C' corresponde a Coagulopatías. La Enfermedad de von Willebrand es la coagulopatía hereditaria más común y se diagnostica en hasta un 20% de las adolescentes que ingresan hospitalizadas por hipermenorrea severa desde su menarquia, especialmente si se acompaña de historia de sangrado mucocutáneo (epistaxis, equimosis, gingivorragia). Debe solicitarse estudio de hemostasia completo (antígeno de vWF, actividad de cofactor de ristocetina y factor VIII). C) Incorrecta. El cáncer endometrial es extraordinariamente infrecuente a los 14 años. D) Incorrecta. Los pólipos son causas estructurales raras en la adolescencia. E) Incorrecta. Los miomas son típicos de mujeres en la 4.ª y 5.ª década de la vida.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: B**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La aspirina es un antiagregante plaquetario que aumenta el sangrado. B) Correcta. El Dispositivo Intrauterino liberador de Levonorgestrel (DIU-LNG / Mirena) es el tratamiento farmacológico no quirúrgico más eficaz disponible en la medicina actual para el SUA no estructural. Al liberar diariamente levonorgestrel directamente en la cavidad uterina, produce una intensa decidualización del estroma y una atrofia endometrial marcada y reversible, reduciendo la pérdida sanguínea menstrual en más de un 90% a los 6 meses, superando con creces a cualquier terapia oral y evitando histerectomías en un alto porcentaje de pacientes. C) Incorrecta. El DIU de cobre tiene como efecto secundario común el AUMENTO del sangrado menstrual y la dismenorrea. D) Incorrecta. Los progestágenos orales continuos son eficaces pero inferiores al DIU-LNG en adherencia y reducción neta. E) Incorrecta. La vitamina K solo es útil en coagulopatías por déficit de factores dependientes o sobredosis de cumarínicos.

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: A**

**Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo**

3.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El sangrado uterino en una mujer postmenopáusica es un síntoma de alarma neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. Aunque la atrofia endometrial es la causa más frecuente en número de casos, el Cáncer de Endometrio es la causa maligna subyacente en el 10 al 15% de las pacientes. Un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una postmenopáusica exige de forma mandatoria la toma de una Biopsia Endometrial para estudio histopatológico definitivo. B) Incorrecta. Aunque la vaginitis atrófica es frecuente, un endometrio de 9 mm (> 4-5 mm) prohíbe atribuir el sangrado a atrofia sin biopsia. C) Incorrecta. Administrar hormonas a ciegas sobre un eventual adenocarcinoma retrasa el tratamiento curativo. D) Incorrecta. Conducta negligente ante metrorragia de la postmenopausia. E) Incorrecta. La cirugía de ovario no diagnostica el sangrado uterino.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

**Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis**

3.01.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confirmar el diagnóstico y descartar el cáncer. La hiperplasia simple se trata con progestágenos. La hiperplasia atípica, en cambio, se trata con histerectomía.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: B**

**Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis**

3.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La histerectomía mutilaría definitivamente su deseo de fertilidad. B) Correcta. En una paciente con deseo de embarazo que presenta un mioma submucoso intracavitario (FIGO 0 o 1) menor de 4-5 cm que causa sangrado o distorsión de la cavidad endometrial, el tratamiento de elección indiscutido es la Miomectomía por Histeroscopía quirúrgica resectoscópica. Es un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y conservador que extirpa el mioma respetando la pared miometrial y restaurando la anatomía endometrial y la fertilidad. C) Incorrecta. La embolización de arterias uterinas puede comprometer la reserva ovárica y aumentar complicaciones obstétricas posteriores, por lo que está formalmente desaconsejada en mujeres con deseo de gestación. D) Incorrecta. Los análogos de GnRH solo se usan por un máximo de 3-6 meses como puente quirúrgico, no como terapia definitiva por riesgo de osteoporosis severa. E) Incorrecta. Los miomas son benignos y la radioterapia no tiene indicación.

---

## BLOQUE 2 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: D**

**Enfermedades de transmisión sexual**

3.01.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Condilomas acuminados genitales en embarazo: La imagen muestra condilomas acuminados, causados por el virus del papiloma humano (VPH), serotipos 6 y 11. A diferencia del herpes genital, los condilomas acuminados no contraindican el parto vaginal. El tratamiento de elección durante el embarazo es el ácido tricloroacético tópico. Otros tratamientos tópicos como el imiquimod y el podofilino, aunque eficaces para tratar los condilomas acuminados, están contraindicados durante el embarazo.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: C** **Mastitis abscedada** 3.01.2.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 64). Evalúa el manejo clínico de Mastitis abscedada según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: E**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Adenomiosis: endometrio ectópico dentro del miometrio → útero grande, globuloso, heterogéneo en ecografía + dismenorrea severa + menometrorragia + dispareunia. Afecta mujeres multíparas >35 años. Tratamiento: AINEs, gestágenos, DIU hormonal o histerectomía.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Endometriosis.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: B**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un endometrioma clásico, tanto por la clínica como por la imagen. Además, tiene la elevación del Ca-125, que, si bien es un marcador de cáncer de ovario, se eleva en otros procesos peritoneales, como la endometriosis.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: C**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta muy discuGble. La clínica orienta fuertemente a una endometriosis (dismenorrea secundaria, progresiva y refractaria), cuyo examen diagnóstico de elección es la laparoscopía (que también es terapéutica) y quien redactó la pregunta probablemente buscaba evaluar la capacidad de reconocer el cuadro clínico de la endometriosis. Sin embargo, aunque no está en las opciones, se recomienda iniciar el estudio con ecografía (que suele estar normal, salvo que haya un endometrioma) y también es correcto tratarla con anticonceptivos orales, ya que atrofian la endometriosis y no Genen el riesgo quirúrgico, por lo que muchas guías internacionales dejan la laparoscopía reservada a 1. No responde a AINES + ACO, 2. InferGlidad y 3. Endometrioma. De todos modos, en este caso, por la severidad de los síntomas y lo ya explicado, dejaremos como correcta la laparoscopía.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: A**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.01.2.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un cuerpo lúteo heorrágico clásico.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: B**

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los analgésicos simples son totalmente insuficientes para una endometriosis sintomática. B) Correcta. En pacientes con endometriosis y dolor pélvico (dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico crónico) que NO desean fertilidad activa inmediata, el tratamiento médico de primera línea de elección respaldado por las guías clínicas internacionales (ESHRE) y el MINSAL es el uso continuo de Progestágenos, siendo el DIENOGEST oral a dosis de 2 mg al día el estándar de oro actual. El dienogest produce decidualización y atrofia directa de las lesiones endometriósicas ectópicas, suprime la ovulación y reduce la inflamación pélvica de forma segura y prolongada. C) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico. D) Incorrecta. El clomifeno estimula la foliculogénesis e induciría mayor crecimiento estrogénico de los implantes. E) Incorrecta. Los estrógenos solos alimentarían y proliferarían agresivamente las lesiones de endometriosis.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: B**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

A) Incorrecta. El cistoadenocarcinoma seroso muestra áreas sólidas, septos gruesos, papilas internas y ascitis con alta vascularización Doppler. B) Correcta. La descripción ecográfica clásica y patognomónica de una masa quística unilocular ovárica con ecos internos finos y homogéneos de bajo nivel descrita como imagen en 'vidrio esmerilado' (ground glass appearance), con pared regular y sin vascularización Doppler interna en una mujer joven con dolor pélvico e infertilidad, corresponde con total precisión a un Endometrioma Ovárico (o 'quiste de chocolate'). C) Incorrecta. El teratoma muestra nódulos ecogénicos murales (tapón de Rokitansky), niveles líquido-grasa y áreas de sombra acústica por calcificaciones o dientes. D) Incorrecta. El quiste folicular es anecoico puro, con refuerzo acústico posterior y sin ecos internos. E) Incorrecta. El absceso tubo-ovárico es una masa compleja multiloculada dolorosa con paredes engrosadas y Doppler hiperémico.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: B**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

A) Incorrecta. No son teratogénicos irreversibles. B) Correcta. La evidencia médica basada en ensayos clínicos aleatorizados y guías internacionales (ESHRE / ASRM) ha demostrado de forma categórica que la supresión médica hormonal de la endometriosis (con ACOs, progestágenos, análogos de GnRH o danazol) NO erradica las adherencias anatómicas ni mejora las tasas acumuladas de embarazo espontáneo tras su retiro, y tiene el efecto deletéreo de anovulación que posterga inútilmente el tiempo reproductivo de la mujer. Ante infertilidad por endometriosis, el camino es la cirugía laparoscópica para reparar la anatomía o la fertilización in vitro (FIV). C) Incorrecta. No ocluyen las trompas. D) Incorrecta. No tienen relación con enfermedad trofoblástica. E) Incorrecta. No aceleran la pérdida folicular.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: A**

3.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado**

A) Correcta. El cuadro de útero uniformemente aumentado de tamaño, blando y doloroso en una multípara de más de 40 años con hipermenorrea y dismenorrea severa corresponde a una Adenomiosis Uterina (o endometriosis interna). La definición anatomopatológica estricta de la adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio a más de 2.5 mm de la capa basal del endometrio, acompañada de hiperplasia e hipertrofia del músculo liso adyacente. B) Incorrecta. Es la definición de mioma. C) Incorrecta. Corresponde a un sarcoma uterino maligno. D) Incorrecta. Es un pólipo cervical. E) Incorrecta. Describe implantes de endometriosis externa peritoneal.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: C**

3.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia**

El Prolapso se evalúa con el POP-Q: un examen físico formal, realizado por un ginecólogo, en el cual se mide el grado de prolapso de las distintas estructuras genitales.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: D**

3.01.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia**

Es una incontinencia de orina de esfuerzos. El orden a tratar es: descartar ITU, luego kinesioterapia pélvica (ejercicios de Koegel) y finalmente la cirugía (suspensión uretral con TOT o TVT).

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: A**

3.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia**

A) Correcta. La Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) confirmada clínicamente que no responde al tratamiento conservador tiene como estándar de oro quirúrgico indiscutido la colocación de un Cabestrillo Mediouretral Libre de Tensión (Slings tipo TOT [Trans-Obturator Tape] o TVT [Tension-free Vaginal Tape]). Estas cintas de polipropileno se ubican debajo de la uretra media por vía vaginal, restableciendo el soporte suburetral y logrando tasas de continencia y curación superiores al 85-90% con baja morbilidad. B) Incorrecta. La toxina botulínica vesical es para la incontinencia de urgencia severa refractaria, no para la de esfuerzo. C) Incorrecta. La oxibutinina es un anticolinérgico para la hiperactividad del detrusor; en la IUE es ineficaz. D) Incorrecta. Es una cirugía mayor reservada para vejigas neurógenas espásticas de escasa capacidad. E) Incorrecta. Procedimiento en desuso y sin rol en IUE.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: B**

**Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia**

3.02.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La cirugía de TOT/TVT está contraindicada en la incontinencia de urgencia porque no trata la hiperactividad del detrusor e incrementa el riesgo de retención urinaria y empeoramiento de la urgencia. B) Correcta. El cuadro clínico de deseo miccional imperioso seguido de escape, acompañado de polaquiuria diurna y nicturia sin esfuerzo asociado corresponde a una Incontinencia Urinaria de Urgencia (Vejiga Hiperactiva). El tratamiento de primera línea no invasivo consiste en medidas higiénico-dietéticas y reeducación vesical con micciones programadas, asociado a tratamiento farmacológico con Antimuscarínicos (Solifenacina, Oxibutinina) para bloquear los receptores colinérgicos del detrusor, o un agonista de receptores beta-3 adrenérgicos (Mirabegrón) que promueve la relajación del detrusor durante el llenado vesical. C) Incorrecta. La restricción extrema de líquidos concentra la orina y estimula aún más el detrusor. D) Incorrecta. No hay estenosis uretral. E) Incorrecta. El sedimento es normal y el uso prolongado de antibióticos genera resistencia innecesaria.

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

**Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida**

3.01.1.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

**PREGUNTA 35** **Respuesta: C**

**Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida**

3.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El semen del esposo es normal y las trompas de la mujer están bloqueadas, por lo que la IIU fracasará independientemente del origen del semen. B) Incorrecta. Las relaciones programadas no sirven si los gametos no pueden encontrarse por la obstrucción física tubárica. C) Correcta. La obstrucción tubárica bilateral no corregible es la indicación clásica y primordial de la Fertilización In Vitro (FIV). La FIV 'bypasea' o salta completamente la necesidad funcional de las trompas de Falopio al aspirar los ovocitos directamente del ovario mediante punción transvaginal, fertilizarlos con los espermatozoides en la placa de cultivo del laboratorio y transferir el embrión resultante directamente a la cavidad endometrial. D) Incorrecta. La Inseminación Intrauterina (IIU) exige como condición indispensable que al menos una trompa esté permeable; al estar ambas bloqueadas, la tasa de éxito de la IIU es del 0%. E) Incorrecta. Los antibióticos no resuelven la fibrosis cicatrizal tubárica establecida.

**PREGUNTA 36** **Respuesta: B**

**Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida**

3.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Una abstinencia menor a 48 horas reduce artificialmente el volumen y el recuento total de espermatozoides. B) Correcta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías clínicas de fertilidad establecen de forma estricta que la recolección de semen para un espermiograma diagnóstico debe realizarse tras un período mínimo de 2 a 3 días y un máximo de 5 a 7 días de abstinencia sexual previa (la recomendación estándar óptima es de 3 a 5 días). Períodos más cortos disminuyen el volumen y concentración espermática, mientras que períodos más prolongados aumentan el recuento a expensas de una drástica caída en la motilidad y viabilidad de los espermatozoides por envejecimiento celular. C) Incorrecta. Abstinencias muy prolongadas aumentan las formas muertas y detritos. D) Incorrecta. Es el parámetro preanalítico más crítico de estandarización. E) Incorrecta. La recolección seminal masculina no depende del día del ciclo femenino.

## BLOQUE 3 ENDOMETRIOSIS, PISO PÉLVICO, INFERTILIDAD & ANTICONCEPCIÓN · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A** **Oligoanovulación crónica**

3.01.1.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Oligoanovulación crónica" (3.01.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

**PREGUNTA 38** **Respuesta: B**

**Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso**

3.01.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Absceso vulvar/hematoma infectado post-parto: aumento de volumen azulado + fluctuante + doloroso a las 48h del parto = hematoma infectado o absceso. Requiere drenaje quirúrgico + antibióticos (amoxicilina-clavulánico). El hematoma no infectado (<24h, sin fiebre) se maneja con compresas frías.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: B**

**Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso**

3.02.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La punción con aguja tiene una tasa de recidiva superior al 80-90% y está proscrita. B) Correcta. El tratamiento de elección para el absceso agudo de la glándula de Bartolino es la incisión y drenaje amplio seguido de MARSUPIALIZACIÓN (sutura de los bordes de la pared de la cápsula a la mucosa vestibular para formar un ostium permanente permeable), o alternativamente la colocación de un Catéter de Word. Estos procedimientos permiten la evacuación del pus y garantizan la formación de una nueva apertura fistulosa definitiva que previene la reobstrucción y recidiva. C) Incorrecta. La vulvectomía es una cirugía mutilante exclusiva de neoplasias malignas invasoras. D) Incorrecta. Los antibióticos no penetran adecuadamente una colección purulenta cerrada a tensión; el drenaje es imperativo. E) Incorrecta. El nitrato de plata quema la superficie sin resolver la cavidad abscedada profunda.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: B**

**Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso**

3.02.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La candidiasis produce eritema inflamatorio agudo y leucorrea en requesón, no atrofia blanquecina esclerosante. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar crónico intratable en una mujer postmenopáusica con placas atróficas blanquecinas apergaminadas en forma de cerradura o en ocho, con reabsorción de labios menores y encapuchamiento del clítoris, es la descripción patognomónica del Liquen Escleroso Vulvar. El tratamiento de primera línea respaldado por todas las guías dermatológicas y ginecológicas consiste en la aplicación tópica de Corticoides Ultrapotentes, siendo el ungüento de Propionato de Clobetasol al 0.05% el fármaco de elección para frenar la inflamación autoinmune y aliviar el prurito. C) Incorrecta. Los condilomas son vegetaciones verrugosas exofíticas por VPH. D) Incorrecta. El herpes causa vesículas dolorosas agrupadas que se ulceran. E) Incorrecta. La psoriasis vulvar se manifiesta como placas eritematosas brillantes no atróficas.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: C**

**Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia**

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El DIU de cobre es Categoría 1 (sin ninguna restricción). B) Incorrecta. El implante de etonogestrel contiene solo progestágeno y es Categoría 1 en fumadoras. C) Correcta. De acuerdo a los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS y a las normas de anticoncepción del MINSAL, ser mujer de 35 años o más y fumar 15 o más cigarrillos al día es una contraindicación formal absoluta (CATEGORÍA 4: Riesgo inaceptable para la salud) para el uso de Anticonceptivos Hormonales Combinados que contengan estrógenos. El sinergismo entre el etinilestradiol y los componentes del tabaco altera severamente la función endotelial y la hemostasia, disparando el riesgo de infarto de miocardio, trombosis venosa y ACV isquémico. D) Incorrecta. El DIU-LNG contiene solo progestágeno local y es totalmente seguro (Categoría 1). E) Incorrecta. La minipíldora de solo progestágeno es Categoría 1 en fumadoras.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: B**

**Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia**

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La mifepristona es un antiprogestágeno utilizado en interrupción del embarazo, no la PAE estándar en Chile. B) Correcta. El método de anticoncepción de emergencia farmacológico de elección en Chile y en los protocolos del MINSAL es el LEVONORGESTREL a dosis única de 1.5 mg por vía oral (o dos comprimidos de 0.75 mg juntos), administrado preferentemente dentro de las primeras 72 horas del coito no protegido. Su mecanismo de acción biológico comprobado consiste en impedir o postergar el pico ovulatorio de LH y la consecuente expulsión del ovocito; NO actúa como un método abortivo, no afecta el endometrio receptivo ni daña un embrión ya implantado. C) Incorrecta. El misoprostol es un abortivo sintético, no anticoncepción de emergencia. D) Incorrecta. El metotrexato es un citotóxico para ectópico. E) Incorrecta. El método de Yuzpe clásico con estrógenos está en desuso por su alta tasa de náuseas y menor eficacia.

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

**Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia**

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. La Migraña con AURA a cualquier edad es una condición de CATEGORÍA 4 de la OMS (Riesgo inaceptable para la salud / contraindicación absoluta) para TODOS los métodos anticonceptivos hormonales combinados (ACOs, parche transdérmico y anillo vaginal). Los estrógenos provocan vasoconstricción y microtrombosis cerebral que, sumados a la fisiopatología vasoespástica del aura migrañosa, elevan drásticamente el riesgo de Infarto Cerebral Isquémico (ACV). En cambio, los métodos de solo progestágeno (implante, DIU-LNG, minipíldora) y el DIU de cobre son completamente seguros. B) Incorrecta. El implante es de solo progestágeno y es seguro en migraña con aura. C) Incorrecta. El DIU de cobre no tiene hormonas y es totalmente seguro. D) Incorrecta. El desogestrel no contiene estrógenos. E) Incorrecta. El DIU-LNG es de solo progestágeno local y seguro.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: B**

**Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia**

3.02.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La absorción gástrica y duodenal de los comprimidos tarda entre 1 y 2 horas. B) Correcta. De acuerdo a las directrices de la OMS y a la Norma General Técnica de Regulación de la Fertilidad del MINSAL, si una mujer vomitara dentro de las PRIMERAS 2 HORAS posteriores a la ingestión de la píldora de anticoncepción de emergencia de Levonorgestrel, se asume que el fármaco no fue absorbido en cantidad terapéutica suficiente y la paciente DEBE tomar una nueva dosis completa de 1.5 mg lo antes posible, pudiendo administrarse previamente un antiemético (como metoclopramida o domperidona) para asegurar la retención gástrica. C) Incorrecta. El método aún puede ser administrado y no se sabe si habrá fecundación. D) Incorrecta. Los antibióticos no tienen ningún rol en la anticoncepción. E) Incorrecta. No resolver la falta de absorción deja a la paciente totalmente desprotegida.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Criterios de Amsel: flujo gris homogéneo + pH >4.5 + test de aminas + (+) células clave = vaginosis bacteriana. Tratamiento: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días o clindamicina vaginal.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: C**

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Vaginosis Bacteriana: El diagnóstico probable es vaginosis bacteriana, que se trata con metronidazol oral, siendo una alternativa la clindamicina tópica. No se debe confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica que se presenta con dolor, flujo purulento y fiebre. El tratamiento para esta última condición consiste en antibióticos (orales o intravenosos según la gravedad) y la extracción del DIU si no hay respuesta en 48 horas.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: E**

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

ITU en embarazo: cefalexina oral 500 mg c/6-8h por 7 días es de primera línea en Chile. Ciprofloxacino: contraindicado (artropatía fetal). Cotrimoxazol: contraindicado en tercer trimestre (kernicterus). Nitrofurantoína: evitar en tercer trimestre. Cefalexina: segura en todos los trimestres.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

3.01.1.019 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

Es una candidiasis genital. De elección se trata con fluconazol 150 mg v.o. por 1 vez.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

3.01.2.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

Sangrado uterino masivo con inestabilidad hemodinámica en postmenopáusica con miomatosis: prioridad = estabilización (fluidos + transfusión si necesario) + histerectomía de urgencia.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

A) Incorrecta. El fluconazol es antifúngico para candidiasis. B) Correcta. La paciente cumple con los 4 Criterios de Amsel para Vaginosis Bacteriana (flujo fino homogéneo blanco-grisáceo, pH > 4.5, test de aminas positivo con KOH y presencia de más de un 20% de células clave o 'clue cells' en el frotis). El tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la OMS es el Metronidazol oral a dosis de 500 mg cada 12 horas durante 7 días (o gel de metronidazol tópico). Es un hecho clínico comprobado que la vaginosis bacteriana NO requiere tratamiento de la pareja sexual masculina de rutina, a diferencia de la tricomoniasis. C) Incorrecta. La ceftriaxona es para cervicitis gonocócica. D) Incorrecta. La nistatina es para hongos. E) Incorrecta. La doxiciclina es para clamidia.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

A) Incorrecta. La vaginosis cursa con pH elevado > 4.5 y test de aminas positivo, sin prurito intenso ni eritema. B) Correcta. La combinación de prurito vulvar severo, antecedente reciente de tratamiento antibiótico, leucorrea espesa grumosa en 'leche cortada' con placas adherentes a una mucosa intensamente eritematosa, asociado a un pH vaginal NORMAL ÁCIDO (< 4.5) y test de aminas negativo es la manifestación clásica e inequívoca de una Candidiasis Vulvovaginal. Se trata con Fluconazol 150 mg oral dosis única o Clotrimazol vaginal. C) Incorrecta. La tricomoniasis cursa con flujo espumoso verdoso, pH alcalino > 5.0 y colpitis en fresa. D) Incorrecta. La cervicitis cursa con secreción endocervical purulenta sin afectación vulvar primaria. E) Incorrecta. La vaginitis atrófica ocurre en la postmenopausia con mucosa pálida y pH alcalino.

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: C**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

A) Incorrecta. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que tratar a la pareja masculina en la vaginosis bacteriana no previene las recurrencias. B) Incorrecta. La candidiasis no se clasifica como una ITS; el tratamiento de la pareja asintomática no está indicado. C) Correcta. La Tricomoniasis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) clásica en la que el varón suele actuar como portador asintomático del protozoo en la uretra y próstata. Por esta razón, el tratamiento simultáneo de la pareja sexual (con Metronidazol 2g oral en dosis única o 500 mg cada 12 horas por 7 días) junto con la indicación de abstinencia coital es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO en todos los casos para prevenir la reinfección inmediata de la mujer y detener la transmisión comunitaria. D) Incorrecta. Es un cuadro no infeccioso idiopático mediado por inmunidad. E) Incorrecta. La cistitis por E. coli no es una ITS y no requiere tratamiento de la pareja.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: B**

3.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis**

A) Incorrecta. El metronidazol no cubre Neisseria gonorrhoeae ni Chlamydia trachomatis. B) Correcta. El cuadro de secreción purulenta endocervical con cuello friable corresponde a una Cervicitis Mucopurulenta aguda. Dado que los dos agentes causales más frecuentes y graves son Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis y que la coinfección es muy habitual, la norma ministerial y los CDC recomiendan el tratamiento empírico inmediato combinado de amplio espectro: Ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única (para gonococo) MÁS Doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral por 7 días (para Chlamydia). Se debe citar a la pareja para tratamiento simultáneo. C) Incorrecta. El gonococo tiene altísima resistencia a aminopenicilinas y no cubre Chlamydia. D) Incorrecta. Es un antifúngico ineficaz contra bacterias. E) Incorrecta. El clotrimazol es un antifúngico tópico.

---

**PREGUNTA 55** **Respuesta: D** **Proceso inflamatorio pelviano** 3.01.1.025 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

**PREGUNTA 56** **Respuesta: B**

**Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos**

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Las fluoroquinolonas tienen elevadísima resistencia para Neisseria gonorrhoeae en Chile y no se recomiendan como monoterapia. B) Correcta. La paciente presenta una Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP) Estadio I de Monif diagnosticada por los Criterios de Hager (dolor hipogástrico, dolor cervical a la movilización, dolor anexial y fiebre). Al ser de manejo ambulatorio, el esquema oficial ministerial y de los CDC es la triple terapia durante 14 DÍAS: 1) Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única (cobertura de gonococo); 2) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura de Chlamydia trachomatis); y 3) Metronidazol 500 mg cada 12 horas por vía oral por 14 días (cobertura indispensable para anaerobios pélvicos). Requiere control clínico en 48-72 horas. C) Incorrecta. No cubre adecuadamente Chlamydia ni alcanza niveles tubáricos óptimos. D) Incorrecta. No cubre gonococo ni clamidia. E) Incorrecta. No cubre clamidia y una dosis única es inútil para EIP.

**PREGUNTA 57** **Respuesta: B**

**Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos**

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Monif I tolera vía oral y es de manejo ambulatorio. B) Correcta. La presencia de un Absceso Tubo-Ovárico (ATO) (Monif Estadio III) es un criterio absoluto e indiscutido de HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA. El ATO conlleva un alto riesgo de rotura intraperitoneal catastrófica con sepsis grave y peritonitis fecal/purulenta, y requiere antibioticoterapia endovenosa continua de amplio espectro a dosis máximas (ej. Ceftriaxona + Doxiciclina + Metronidazol o Clindamicina + Gentamicina) y monitorización intrahospitalaria estricta para definir si responde o requiere drenaje quirúrgico. C) Incorrecta. El antecedente previo no obliga a hospitalizar si el episodio actual es leve. D) Incorrecta. Se trata ambulatoriamente. E) Incorrecta. Se debe insistir en el contacto, pero no es criterio médico de ingreso.

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

**Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos**

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis o Perihepatitis asociada a EIP es una complicación clásica provocada por la diseminación ascendente transperitoneal de Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae desde la pelvis a lo largo de las correderas parietocólicas hacia el espacio perihepático. Cursa con dolor agudo en hipocondrio derecho (que simula colecistitis o pleuritis) y formación característica de adherencias peritoneales translúcidas en 'cuerdas de violín' entre la cápsula hepática y el diafragma/pared anterior. El tratamiento consiste en completar el esquema antibiótico para EIP, el cual es altamente curativo. B) Incorrecta. No produce adherencias en cuerdas de violín. C) Incorrecta. Es la trombosis de suprahepáticas con hepatomegalia y ascitis masiva. D) Incorrecta. Lesión ocupante de espacio piógena hepática. E) Incorrecta. Infección supurativa con trombosis portal.

**PREGUNTA 59** **Respuesta: B**

**Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos**

3.02.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La colonoscopía está absolutamente contraindicada ante peritonitis perforada. B) Correcta. El deterioro clínico catastrófico repentino con dolor peritoneal difuso, contractura abdominal en tabla (vientre peritoneal) e inestabilidad hemodinámica severa (shock séptico/hipovolémico) en una paciente hospitalizada por un ATO representa una Rotura de Absceso Tubo-Ovárico (Estadio IV de Monif). Es una emergencia quirúrgica de extrema gravedad con altísima mortalidad materna. La conducta mandatoria es la resucitación hemodinámica con fluidos y traslado inmediato a pabellón para LAPAROTOMÍA EXPLORADORA DE URGENCIA con lavado profuso de la cavidad abdominal, desbridamiento y salpingooforectomía del anexo comprometido. C) Incorrecta. La heparina no trata la peritonitis purulenta. D) Incorrecta. Esperar ante un shock séptico por rotura de ATO conduce a la muerte de la paciente en pocas horas. E) Incorrecta. El cuadro es estrictamente peritoneal pélvico.

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A**

**Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos**

3.02.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. En una mujer menopáusica sintomática histerectomizada (sin útero) que no tiene contraindicaciones, el tratamiento hormonal de elección indiscutido es la Monoterapia con Estrógenos Solos (ej. 17-beta estradiol oral o transdérmico). Dado que la paciente no tiene útero, no existe riesgo de hiperplasia ni adenocarcinoma de endometrio, por lo que NO se debe prescribir progestágeno; la adición innecesaria de progestágenos aumenta el riesgo de cáncer de mama y eventos adversos sin aportar ningún beneficio clínico adicional. B) Incorrecta. El progestágeno solo se añade para proteger el endometrio en pacientes con útero intacto. C) Incorrecta. Los progestágenos solos son inferiores para sofocos y no aportan protección ósea ni vascular. D) Incorrecta. No es la indicación para síntomas vasomotores del climaterio. E) Incorrecta. La histerectomía previa no es contraindicación; al contrario, simplifica la TRH a estrógenos puros.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos**

3.02.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El antecedente personal o la sospecha de Cáncer de Mama es una CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA para cualquier formulación de Terapia de Reemplazo Hormonal sistémica, debido a que los estrógenos estimulan la proliferación de células mamarias residuales y aumentan drásticamente el riesgo de recidiva o progresión tumoral. En estas pacientes, los bochornos deben manejarse con alternativas no hormonales (como venlafaxina, paroxetina o gabapentina). B) Incorrecta. La osteoporosis es una indicación aprobada de TRH en mujeres dentro de la ventana de oportunidad. C) Incorrecta. La atrofia es una indicación directa de tratamiento. D) Incorrecta. La menopausia precoz es una indicación prioritaria de TRH para proteger corazón y hueso hasta los 50 años. E) Incorrecta. Es la indicación clásica y óptima de TRH.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: A**

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopía (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: B**

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Cáncer cervicouterino.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: C**

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

3.01.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Biopsia cervical

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: B**

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Manejo de ASCUS (Células Escamosas Atípicas de Significado Incierto): Vale la pena recordar que las indicaciones más importantes para realizar una colposcopía y biopsia cervical son: Lesión cervical independiente del resultado de la prueba de Papanicolaou (PAP). PAP de tipo glandular, independientemente del grado. PAP escamoso de alto grado. Presencia del virus del papiloma humano (VPH) de alto grado, independientemente del resultado del PAP. PAP escamoso de bajo grado con VPH de bajo grado. Con lo anterior, se puede deducir el manejo de las ASCUS: existes 3 opciones: observar, controlar en 1 año y solicitar una prueba de VPH (la más aceptada). Si VPH(+): Se realiza colposcopía y biopsia, ya que cumple con el criterio de PAP de bajo grado más VPH de bajo grado. Si VPH(-): Se puede optar por la observación o un nuevo PAP en 6 a 12 meses. La opción más recomendada por las guías internacionales es solicitar un nuevo PAP. En menores de 25 años con ASCUS, también se solicita la prueba de VPH, pero se sigue en 1 (si VPH+) o 3 años (si VPH-).

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: C**

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

El PAP de alto grado siempre va a colposcopía y biopsia. La tipificación de VPH no ha demostrado ser un buen examen y la guía Minsal solo lo tiene como opción ante el ASCUS (PAP de bajo grado) y no para el ASCH (alto grado).

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

3.01.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: B**

3.01.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

Es una enfermedad de Paget clásica, que es una Gpo de cáncer de mama, en específico un carcinoma in situ, que se exGende por el pezón y la areola. Es característico el engrosamiento de la piel, con descamación y presencia de costras. Se debe buscar la presencia de otro cáncer de mama (mamografías, etc.). Se diagnostica con biopsia. El tratamiento es resorte del especialista. Fuente imagen: hxps://www.revistamsp.com.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: B**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

A) Incorrecta. Repetir el PAP posterga inaceptablemente el diagnóstico de una lesión premaligna de alto grado que puede albergar cáncer invasor oculto. B) Correcta. En el marco del Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino (GES N° 3), todo informe de PAP con Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIEAG / H-SIL) exige la notificación de garantía GES y la derivación inmediata y obligatoria a la Unidad de Patología Cervical (UPC) de nivel secundario para la realización de una Colposcopía con biopsia dirigida y eventual legrado endocervical en un plazo máximo garantizado de 30 días. C) Incorrecta. Los óvulos no tratan las neoplasias intraepiteliales. D) Incorrecta. La histerectomía sin confirmación diagnóstica colposcópica e histológica previa es una mala praxis quirúrgica grave. E) Incorrecta. La vacuna es profiláctica, no tiene ningún efecto terapéutico sobre lesiones preexistentes.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: C**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

A) Incorrecta. La cirugía radical está formalmente CONTRAINDICADA cuando el tumor invade los parametrios (Estadio IIB en adelante), debido a que no permite lograr bordes quirúrgicos libres y aumenta masivamente las fístulas urinarias sin beneficio en sobrevida. B) Incorrecta. La conización es exclusiva de lesiones preinvasoras o microinvasoras IA1. C) Correcta. El límite biológico y quirúrgico consensuado internacionalmente (FIGO, NCCN, MINSAL) para operar el cáncer cervicouterino es la indemnidad de los parametrios. Desde el momento en que existe invasión parametrial demostrada al tacto rectovaginal (Estadio IIB), el tratamiento curativo estándar de elección es la Quimiorradioterapia Concomitante basada en Cisplatino semanal asociado a Radioterapia Externa pélvica y Braquiterapia intracavitaria de alta tasa de dosis. Este esquema alcanza excelentes tasas de control local sin la morbilidad de una cirugía no R0. D) Incorrecta. La histerectomía simple deja tumor parametrial activo. E) Incorrecta. El Estadio IIB es potencialmente curable con quimiorradioterapia definitiva.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: B**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

A) Incorrecta. El tamizaje masivo anual en menores de 25 años sobretrata infecciones transitorias por VPH sin reducir la mortalidad. B) Correcta. La Guía Clínica de Cáncer Cervicouterino del MINSAL y las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 3) definen que la población beneficiaria de tamizaje poblacional universal está constituida por las mujeres de 25 a 64 años de edad, mediante el examen de Papanicolaou (PAP) cada 3 años (tras dos controles anuales iniciales consecutivos negativos). Este intervalo trienal maximiza el costo-efectividad y reduce la incidencia de cáncer invasor en más del 80%. C) Incorrecta. El rango 50 a 69 años bienal corresponde al tamizaje de Cáncer de Mama por mamografía. D) Incorrecta. El uso de ACOs no altera el intervalo trienal de tamizaje. E) Incorrecta. El tamizaje debe ser periódico a lo largo de toda la vida reproductiva y perimenopáusica.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: B**

**Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía**

3.02.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los serotipos 6 y 11 son de bajo riesgo oncogénico y son los causantes del 90% de los condilomas acuminados (verrugas anogenitales benignas). B) Correcta. Los serotipos 16 y 18 del Virus Papiloma Humano son los principales agentes carcinogénicos de alto riesgo oncogénico para el epitelio cervical. El serotipo 16 es responsable de aproximadamente el 55-60% de los carcinomas epidermoides de cuello uterino, y el serotipo 18 es responsable del 15% de los carcinomas epidermoides y de más del 50% de los adenocarcinomas endocervicales. Ambos están cubiertos por la vacuna del PNI chileno. C) Incorrecta. Los serotipos 1 y 2 causan verrugas vulgares y plantares cutáneas. D) Incorrecta. Son serotipos de bajo riesgo. E) Incorrecta. Asociados a epidermodisplasia verruciforme en piel.

## BLOQUE 5 ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA & PATOLOGÍA MAMARIA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: C** **Tumores ováricos**

3.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es un cáncer de ovario clásico.

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B**

**Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna**

3.01.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un fibroadenoma clásico (joven con nódulo liso y móvil).

**PREGUNTA 75** **Respuesta: B**

**Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna**

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El control a los 6 meses es la conducta exclusiva de la categoría BI-RADS 3 (< 2% de riesgo), jamás de una lesión BI-RADS 4. B) Correcta. Todo hallazgo radiológico clasificado como BI-RADS 4 (sospechoso de malignidad con riesgo de 2 a 95%) o BI-RADS 5 (> 95%) tiene indicación formal y mandatoria de confirmación histológica mediante Biopsia Percutánea con Aguja Gruesa (Core Biopsy o Tru-Cut) guiada por ecografía o estereotaxia. Este procedimiento obtiene cilindros de tejido que permiten diagnosticar invasión del estroma y realizar el panel inmunohistoquímico completo (RE, RP, HER2 y Ki-67). C) Incorrecta. Mutilar una mama sin diagnóstico histológico previo es una mala praxis inadmisible. D) Incorrecta. La PAAF solo aporta células aisladas que no permiten distinguir carcinoma in situ de carcinoma invasor ni medir adecuadamente los receptores. E) Incorrecta. La hormonoterapia requiere confirmación histológica de neoplasia con receptores positivos.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna**

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. El estándar oncológico internacional y las guías del MINSAL establecen como regla de oro indiscutible que TODA Cirugía Conservadora de Mama (tumorectomía o cuadrantectomía) DEBE ir seguida obligatoriamente de RADIOTERAPIA EXTERNA ADYUVANTE sobre la glándula mamaria residual. Los ensayos clínicos clásicos (NSABP B-06) demostraron que la cirugía conservadora MÁS radioterapia ofrece exactamente la misma tasa de sobrevida global a largo plazo que la mastectomía radical, pero omitir la radioterapia eleva la tasa de recidiva local a más del 25-35%. B) Incorrecta. El metotrexato intratecal es para leucemias o metástasis meníngeas. C) Incorrecta. El vaciamiento axilar se evita si el ganglio centinela es negativo. D) Incorrecta. No tiene indicación en cáncer de mama. E) Incorrecta. Omitir la radioterapia tras tumorectomía es un error terapéutico grave.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: B**

**Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna**

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El fibroadenoma es un nódulo móvil que no se comunica con los conductos principales ni produce telorrea hemática. B) Correcta. La causa benigna más frecuente de telorrea serohemática o hemática unilateral, unicanalicular (que brota por un único poro del pezón) y espontánea en mujeres en edad reproductiva o perimenopáusica es el Papiloma Intraductal Benigno. Consiste en una pequeña proliferación de epitelio ductal vascularizado que asienta en los conductos galactóforos principales retroareolares. Debe estudiarse con ecografía/mamografía y resolverse mediante resección del conducto afectado (microdoquectomía) para descartar un carcinoma papilar subyacente. C) Incorrecta. El prolactinoma produce galactorrea (leche blanquecina) bilateral, pluriorificial y sin sangre. D) Incorrecta. Cursa con masa inflamatoria dolorosa abscedada recurrente. E) Incorrecta. La ectasia ductal produce secreción pluriorificial, bilateral, espesa y verdosa/pardusca.

**PREGUNTA 78** **Respuesta: B**

3.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

**Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna**

A) Incorrecta. El tamoxifeno requiere que los receptores de estrógeno sean positivos. B) Correcta. El tumor que resulta negativo para los tres marcadores clásicos (RE negativo, RP negativo y HER2 negativo) se clasifica como Cáncer de Mama Triple Negativo. Representa aproximadamente el 15% de los cánceres mamarios y se asocia con mayor frecuencia a pacientes jóvenes y portadoras de mutaciones en el gen BRCA1. Desde el punto de vista terapéutico, al carecer de receptores hormonales y de la proteína HER2, este tumor NO se beneficia de la hormonoterapia (tamoxifeno/anastrozol) ni de la terapia dirigida anti-HER2 (Trastuzumab); su tratamiento médico descansa fundamentalmente en la Quimioterapia Citotóxica combinada. C) Incorrecta. El HER2 es negativo; el trastuzumab es ineficaz. D) Incorrecta. Los inhibidores de aromatasa exigen receptores hormonales positivos. E) Incorrecta. El triple negativo es un carcinoma muy agresivo con alta tasa de recidiva temprana.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: E**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

Caso clínico oficial EUNACOM para Patología maligna del endometrio.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: D**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

Tiene una metrorragia posmenopáusica, que por tener un endometrio de 5 mm o más, debe biopsiarse con técnica Pipelle. El antecedente de tamoxifeno aumenta mucho el riesgo de cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial (premaligna).

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: D**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

Por tener metrorragia postmenopáusica, más un endometrio mayor o igual a 5 mm, se debe biopsiar (con TRH es mayor o igual a 9 mm).

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: E**

3.01.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

Solicitar biopsia endometrial

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: B**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

A) Incorrecta. Los estrógenos locales tratan la atrofia, pero ante un endometrio de 12 mm retrasarían el diagnóstico de un adenocarcinoma. B) Correcta. El sangrado postmenopáusico es el síntoma de presentación del Cáncer de Endometrio en el 90% de los casos. La presencia de un grosor endometrial ecográfico ≥ 4 a 5 mm en una mujer menopáusica exige de forma mandatoria e impostergable la obtención de una muestra histológica mediante Biopsia Endometrial (la aspiración ambulatoria con cánula de Pipelle es el método de primera línea por su alta sensibilidad y bajo costo, recurriéndose a histeroscopía si la muestra no es concluyente). C) Incorrecta. El PET-CT no sustituye la biopsia histológica primaria. D) Incorrecta. La conducta expectante ante sospecha de neoplasia ginecológica es negligencia. E) Incorrecta. La causa del sangrado reside en el endometrio uterino, no en los ovarios.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: B**

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los quistes foliculares solo ocurren en mujeres fértiles ovuladoras, no en postmenopáusicas de 65 años. B) Correcta. La constelación clínica de síntomas digestivos subagudos (distensión, saciedad precoz) asociada a ascitis, una masa anexial con todos los criterios IOTA de malignidad (multiloculada, tabiques gruesos, papilas sólidas y flujo Doppler central) y un marcador tumoral CA-125 marcadamente elevado en una mujer postmenopáusica es diagnóstica de Cáncer Epitelial de Ovario Avanzado. La conducta es la derivación urgente a un centro terciario oncológico para cirugía citorreductora primaria máxima (debulking) y posterior quimioterapia con carboplatino y paclitaxel. C) Incorrecta. La punción percutánea o transvaginal de una masa ovárica con sospecha de cáncer está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA por el gravísimo riesgo de rotura capsular y siembra masiva de células tumorales en la cavidad peritoneal. D) Incorrecta. Los endometriomas no tienen papilas ni se asocian a ascitis masiva en postmenopáusicas. E) Incorrecta. El cuadro es una neoplasia ovárica primaria con carcinomatosis.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: B**

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. No causa hemorragia digestiva. B) Correcta. La punción evacuadora de un tumor ovárico sospechoso de cáncer está estrictamente proscrita en la ginecología oncológica moderna. Si el tumor corresponde a un carcinoma ovárico confinado al ovario (Estadio IA), la punción accidental o deliberada de la cápsula produce el derrame de líquido cargado de células neoplásicas viables hacia el peritoneo libre, transformando inmediatamente la enfermedad en un Estadio IC (peor pronóstico) y multiplicando drásticamente el riesgo de carcinomatosis peritoneal y muerte. Toda masa ovárica sospechosa debe extirparse quirúrgicamente íntegra sin romper su cápsula. C) Incorrecta. La elevación de CA-125 es un marcador tumoral secundario, no el daño biológico. D) Incorrecta. No tiene que ver con permeabilidad tubárica. E) Incorrecta. Salvo el excepcional estruma ovárico, no causa tirotoxicosis.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: C**

**Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores**

3.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La multiparidad es un factor protector (la progesterona del embarazo descama y protege el endometrio). B) Incorrecta. Los ACOs combinados protegen fuertemente contra el cáncer de endometrio (reducen el riesgo en un 50%). C) Correcta. El adenocarcinoma de endometrio tipo I es un tumor hormonodependiente vinculado a la exposición prolongada a estrógenos sin la oposición protectora de la progesterona ('estrógenos sin oposición'). La Obesidad es el factor de riesgo más importante en países occidentales, debido a que el exceso de tejido adiposo contiene enzima aromatasa que convierte masivamente los andrógenos suprarrenales (androstenediona) en estrona. Asimismo, el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) perpetúa ciclos anovulatorios crónicos sin fase lútea ni secreción de progesterona. D) Incorrecta. Curiosamente, el tabaquismo ejerce un leve efecto antiestrogénico hepático y reduce discretamente el riesgo de cáncer de endometrio (aunque aumenta muchos otros cánceres). E) Incorrecta. El DIU-LNG produce atrofia endometrial y es fuertemente protector.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: D**

**Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico**

3.01.2.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Torsión ovárica: Aunque el cuadro clínico inicial puede asemejarse al de una apendicitis aguda, la presencia de un tumor anexial en la ecografía sugiere una torsión ovárica. El tamaño del tumor es un factor de riesgo importante: los tumores de más de 10 cm presentan el mayor riesgo, mientras que los que miden más de 5 cm tienen un riesgo intermedio. En este caso, incluso si el flujo Doppler color en la ecografía hubiera sido normal, la presencia de un tumor anexial grande en el contexto clínico descrito obliga a realizar una laparoscopía urgente, de modo de destorsionar el ovario inmediatamente y prevenir la necrosis ovárica.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: B**

**Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico**

3.02.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Enviar a domicilio a una paciente con torsión ovárica causa la necrosis y pérdida irreversible del ovario en pocas horas. B) Correcta. La Torsión Ovárica es una emergencia quirúrgica isquémica por compromiso vascular del ligamento infundíbulo-pélvico. En mujeres jóvenes en edad reproductiva, el estándar quirúrgico internacional exige la intervención inmediata mediante Laparoscopía de urgencia para realizar la DETORSIÓN OVÁRICA CONSERVADORA (desenrollar el anexo sobre su eje) para restaurar el flujo sanguíneo y preservar el parénquima ovárico y la fertilidad. El ovario tiene una extraordinaria capacidad de recuperación funcional aun tras horas de isquemia clínica. C) Incorrecta. La punción no resuelve la torsión del pedículo y agrega riesgo de infección. D) Incorrecta. No es un cuadro infeccioso; el compromiso es isquémico mecánico. E) Incorrecta. La ooforectomía sistemática de entrada sin intentar detorsión es una práctica desaconsejada y mutilante en mujeres jóvenes.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: B**

**Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico**

3.02.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La cirugía abierta es invasiva y desproporcionada para un cuadro estable. B) Correcta. El cuadro clínico de dolor pélvico agudo postcoital en fase lútea tardía, asociado a los hallazgos ecográficos patognomónicos de un quiste con patrón reticular en 'red de pesca' y líquido libre escaso en una paciente hemodinámicamente estable (PA 118/74, FC 78, hematocrito normal de 40%), corresponde a un Quiste Ovárico Hemorrágico Roto no complicado. La conducta de elección es el MANEJO MÉDICO CONSERVADOR EXPECTANTE con analgesia, reposo y observación clínica. El sangrado del lecho quístico se autolimitada espontáneamente y el hemoperitoneo leve se reabsorbe sin necesidad de cirugía. C) Incorrecta. La laparoscopía solo está indicada si existe inestabilidad hemodinámica, hemoperitoneo masivo o caída persistente del hematocrito. D) Incorrecta. El metotrexato es para el embarazo ectópico (la prueba de gestación fue negativa). E) Incorrecta. La paciente tiene un hematocrito normal y no requiere transfusión.

---

1ª EDICIÓN · 2026

TOMO 21 · ASOFAMECh PERFIL V3

MÓDULO 4

# SALUD PÚBLICA

## 90 Preguntas de Práctica

Epidemiología & Bioética

# MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Salud Pública · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 21 · PARTE A: POR BLOQUES

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 1: SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | |
| 7.01.3.002 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.004 | Niveles de prevención | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.006 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.007 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.009 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.025 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.027 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.029 | Descripción sistemática de problemas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.031 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.032 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.034 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q16 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.035 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.036 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 21 · 21.1 (Pág. 5) |
| 7.01.3.037 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.038 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.039 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.040 | Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | GES | Q13 | Tomo 21 · 21.2 (Pág. 9) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Garantías Legales y Reclamos | **Derivar** | | | |
| 7.01.3.042 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| **BLOQUE 2: SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | |
| 7.01.3.001 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Evaluación Biopsicosocial** Tx: **Plan de Cuidado Familiar** · Seg: **Sector Sanitario / CESFAM** | GES | Q23 | Tomo 21 · 21.5 (Pág. 19) |
| 7.01.3.003 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.005 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.008 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.010 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.011 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q26 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.012 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q27 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.013 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q29 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.014 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.015 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.016 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q22 | Tomo 21 · 21.4 (Pág. 15) |
| 7.01.3.017 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q28 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.018 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.020 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 21 · 21.6 (Pág. 24) |
| 7.01.3.021 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.022 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.023 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.024 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| **BLOQUE 3: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE** | | | | | |
| 7.01.3.019 | Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48 | Tomo 21 · 21.7 (Pág. 28) |
| 7.01.3.026 | Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53, Q54 | Tomo 21 · 21.9 (Pág. 36) |
| 7.01.3.028 | Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49, Q50, Q51 | Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32) |
| 7.01.3.033 | Bases conceptuales de la seguridad social | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.043 | Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.044 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.046 | Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.047 | Auditoría y acreditación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.049 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.050 | Rol del médico en la generación y uso de la información | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.053 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.055 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| **BLOQUE 4: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE** | | | | | |
| 7.01.3.028 | Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos | Dx: **Fase Preclínica Detectable** Tx: **Intervención Precoz Eficaz** · Seg: **Evaluación de Programas** | GES | Q56, Q57, Q58, Q59, Q60 | Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32) |
| 7.01.3.030 | Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.041 | Conceptos de administración y gestión | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.052 | Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 21 · 21.11 (Pág. 43) |
| 7.01.3.056 | Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q68, Q69, Q70, Q71, Q72 | Tomo 21 · 21.12 (Pág. 47) |
| **BLOQUE 5: BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO** | | | | | |
| 7.01.3.045 | Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.051 | Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 21 · 21.13 (Pág. 49) |
| 7.01.3.054 | Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90 | Tomo 21 · 21.14 (Pág. 53) |

# ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Salud Pública · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 21 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.001 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Evaluación Biopsicosocial** Tx: **Plan de Cuidado Familiar** · Seg: **Sector Sanitario / CESFAM** | GES | Q23 | Tomo 21 · 21.5 (Pág. 19) |
| 7.01.3.002 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q3 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.003 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q19 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.004 | Niveles de prevención | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q1 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.005 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q20 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.006 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q4 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.007 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q5 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.008 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q24 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.009 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q6 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.010 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q25 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.011 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q26 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.012 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q27 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.013 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q29 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.014 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q30 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.015 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q21 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.016 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q22 | Tomo 21 · 21.4 (Pág. 15) |
| 7.01.3.017 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | — | Q28 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | **Derivar** | | | |
| 7.01.3.018 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q31 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.019 | Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q46, Q47, Q48 | Tomo 21 · 21.7 (Pág. 28) |
| 7.01.3.020 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q32 | Tomo 21 · 21.6 (Pág. 24) |
| 7.01.3.021 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q33 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.022 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q34 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.023 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q35 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.024 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q36 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.025 | Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q18 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.026 | Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q52, Q53, Q54 | Tomo 21 · 21.9 (Pág. 36) |
| 7.01.3.027 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q7 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.028 | Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q49, Q50, Q51, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60 | Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32) |
| 7.01.3.029 | Descripción sistemática de problemas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q2 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.030 | Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q61 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.031 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q14 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.032 | Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q15 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.033 | Bases conceptuales de la seguridad social | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q37 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.034 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q16 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.035 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q17 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.036 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q8 | Tomo 21 · 21.1 (Pág. 5) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.3.037 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q9 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.038 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q10 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.039 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q11 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.040 | Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q13 | Tomo 21 · 21.2 (Pág. 9) |
| 7.01.3.041 | Conceptos de administración y gestión | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q55 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.042 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q12 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.043 | Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q44 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.044 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q41 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.045 | Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q73 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.046 | Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q38 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.047 | Auditoría y acreditación | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q39 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.049 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q42 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.050 | Rol del médico en la generación y uso de la información | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q40 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.051 | Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82 | Tomo 21 · 21.13 (Pág. 49) |
| 7.01.3.052 | Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67 | Tomo 21 · 21.11 (Pág. 43) |
| 7.01.3.053 | Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q45 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.054 | Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | GES | Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90 | Tomo 21 · 21.14 (Pág. 53) |
| 7.01.3.055 | Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar** | — | Q43 | Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8) |
| 7.01.3.056 | Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha | Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: | GES | Q68, Q69, Q70, Q71, | Tomo 21 · 21.12 (Pág. 47) |

| CÓDIGO V3 | SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA | NIVEL LEGAL EXIGIDO | GES | PREGUNTAS | MANUAL DE ESTUDIO AEE |
|---|---|---|---|---|---|
| | Clínica y Confidencialidad | Derivar | | Q72 | |

# SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

## BLOQUE 1 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PREGUNTA 1 7.01.3.004

**1.** **¿A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Conjunto de medidas des8nadas a evitar que una enfermedad ocurra, actuando antes de que exista la enfermedad o el daño causado por esta”?**

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Prevención cuaternaria
E) Promoción de la salud

PREGUNTA 2 7.01.3.029

**2.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Descripción sistemática de problemas · 7.01.3.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Descripción sistemática de problemas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 7.01.3.002

**3.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Funciones esenciales de la Salud Pública · 7.01.3.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Funciones esenciales de la Salud Pública. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 7.01.3.006

**4.** **Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, ¿cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en la salud de la población?**

A) Nivel educacional
B) Vivienda
C) Alimentación
D) Ingreso económico
E) Acceso a servicios de salud

PREGUNTA 5 7.01.3.007

**5.** **En una zona rural del país se recibe una gran can8dad de migrantes, principalmente personas jóvenes y sanas. Desde el punto de vista de la ges8ón en salud pública para dicha zona, ¿qué medida debe priorizarse?**

A) Aumentar los recursos para el programa de enfermedades crónicas
B) Aumentar los recursos para los programas de atención materno-infan2l
C) Reforzar los programas de saneamiento básico
D) Realizar empadronamiento de los migrantes
E) Aumentar el número de camas hospitalarias

PREGUNTA 6 7.01.3.009

**6. ¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?**

A) La tasa de mortalidad por influenza
B) La tasa de letalidad de la influenza
C) La tasa de incidencia de influenza
D) La tasa de prevalencia de influenza
E) La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

PREGUNTA 7 7.01.3.027

**7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Investigación epidemiológica · 7.01.3.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Investigación epidemiológica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 7.01.3.036

**8. Una empresa extranjera dedicada a otorgar prestaciones en salud decide iniciar sus operaciones en Chile, para lo cual solicita saber cuál es la ins8tución que actúa como laboratorio de referencia para todos los laboratorios, tanto públicos como privados, en el país. ¿Cuál es la respuesta correcta?**

A) Central fíacional de Abastecimiento
B) Ins2tuto de Salud Pública
C) Superintendencia de Salud
D) Servicio Médico Legal
E) Secretaría Regional Ministerial de Salud

PREGUNTA 9 7.01.3.037

**9. [ATENCIÓN PRIMARIA: Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile · 7.01.3.037] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 7.01.3.038

**10. Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:**

A) Administrar el seguro de cotización individual
B) Administran el seguro público de salud
C) Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
D) Administran el seguro general de salud
E) Dan prestaciones de salud

PREGUNTA 11 7.01.3.039

**11. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un centro de atención secundaria?**

A) CESFAM
B) CECOSF
C) Posta de salud rural
D) Hospital comunitario de familia
E) COSAM

PREGUNTA 12 7.01.3.042

**12. En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?**

A) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
B) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
C) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
D) La planificación se basa en lo determinado con la programación
E) La planificación se relaciona a los costes y recursos de actividades concretas y la programación se relaciona con el presupuesto general del proyecto

PREGUNTA 13 7.01.3.040

**13.** **Una paciente de 36 años presenta un trabajo de parto prematuro a las 28 semanas con resultado de mor8nato de 800 g y anencefalia. Según la norma8va vigente, ¿por cuánto 8empo debe recibir descanso laboral?**

A) 7 días
B) 10 días
C) 6 semanas
D) 12 semanas
E) 24 semanas

PREGUNTA 14 7.01.3.031

**14.** **Durante una pandemia respiratoria, el Ministerio de Salud debe decidir la intervención de salud pública con mayor impacto para reducir la mortalidad poblacional a largo plazo. ¿Cuál es la medida más eficaz?**

A) Profilaxis antibiótica masiva
B) Desinfección ambiental de espacios públicos
C) Cuarentena de contactos
D) Vacunación masiva de la población
E) Aislamiento de casos positivos solamente

PREGUNTA 15 7.01.3.032

**15.** **¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?**

A) Tasa de incidencia de cáncer de mama
B) Tasa de prevalencia de cáncer de mama
C) Tasa de letalidad de cáncer de mama
D) Tasa de mortalidad de cáncer de mama
E) Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama

PREGUNTA 16 7.01.3.034

**16.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud · 7.01.3.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 17 7.01.3.035

**17.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Funciones de los sistemas de atención de salud · 7.01.3.035] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Funciones de los sistemas de atención de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 7.01.3.025

**18.** **En un estudio se realiza medición de los niveles plasmáticos de pesticidas a personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedios para la población de cada país. Luego, se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. ¿A qué tipo de estudio corresponde?**

A) Observacional
B) Cohortes
C) Experimental
D) Ecológico
E) De contraste de hipótesis

PREGUNTA 19 7.01.3.003

**19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Historia natural de la enfermedad · 7.01.3.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Historia natural de la enfermedad. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 7.01.3.005

**20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Promoción de salud y prevención de enfermedades · 7.01.3.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Promoción de salud y prevención de enfermedades. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 7.01.3.015

**21. ¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?**

A) Tasa de incidencia
B) Tasa de prevalencia
C) Tasa de hospitalizaciones
D) Tasa de mortalidad
E) Tasa de cobertura de vacunación

PREGUNTA 22 7.01.3.016

**22. El médico de un CESFAM detecta un brote de hepatitis A en su sector. ¿A qué autoridad sanitaria debe notificar de forma inmediata?**

A) SEREMI de Salud
B) Ministerio de Salud directamente
C) FONASA
D) ISP
E) Municipalidad

PREGUNTA 23 7.01.3.001

**23. Durante la realización de un estudio de familia en un CESFAM, se aplica el cuestionario de APGAR familiar a un adolescente de 15 años con conductas de riesgo y deserción escolar, obteniendo un puntaje total de 5 puntos. ¿Cómo se clasifica la funcionalidad de su sistema familiar según este resultado?**

A) Disfunción familiar leve
B) Familia altamente funcional
C) Disfunción familiar severa
D) Familia desestructurada con riesgo de abandono
E) Sistema familiar con aglutinamiento patológico

PREGUNTA 24 7.01.3.008

**24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diagnóstico de situación de salud: · 7.01.3.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diagnóstico de situación de salud:. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 7.01.3.010

**25. La última fase del diagnóstico de salud participativo es:**

A) La comprobación de los problemas de salud, referidos por la comunidad
B) La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos
C) La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad
D) La definición de estrategias de intervención, priorizadas
E) Realización de estudios experimentales

PREGUNTA 26 7.01.3.011

**26. [ATENCIÓN PRIMARIA: Fuentes de información para el diagnóstico · 7.01.3.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Fuentes de información para el diagnóstico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 27 7.01.3.012

**27. [ATENCIÓN PRIMARIA: Ejecución de un diagnóstico · 7.01.3.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Ejecución de un diagnóstico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 28 7.01.3.017

**28. [ATENCIÓN PRIMARIA: Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud · 7.01.3.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 29 7.01.3.013

**29. [ATENCIÓN PRIMARIA: Concepto y campo de la epidemiología · 7.01.3.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Concepto y campo de la epidemiología. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 30 7.01.3.014

**30. Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuales son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:**

A) Analitico

B) Ecológico

C) Descriptivo

D) Control sano habitual

E) Derivar a especialista

PREGUNTA 31 7.01.3.018

**31.** **¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información, a través del contraste de hipótesis?**

A) Epidemiología descriptiva
B) Bioestadística
C) Prevención de salud
D) Epidemiología analítica
E) Vigilancia epidemiológica

PREGUNTA 32 7.01.3.020

**32.** **¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad en una po- blación?**

A) Estudio de serie de casos
B) Estudio de series temporales
C) Estudio de casos y controles
D) Estudio de cohorte
E) Estudio clínico no randomizado

PREGUNTA 33 7.01.3.021

**33.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Estudios de prevalencia · 7.01.3.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Estudios de prevalencia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 7.01.3.022

**34.** **¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?**

A) Cohortes prospectivas
B) Caso control
C) De prevalencia
D) Ensayo clínico
E) Cohortes retrospectiva

PREGUNTA 35 7.01.3.023

**35.** **Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:**

A) Corte transversal
B) Caso control
C) Estudio clínico randomizado
D) Cohorte
E) Ensayo de campo

PREGUNTA 36 7.01.3.024

**36.** **La característica de los estudios experimentales, que los diferencian de los demás tipos de estudios es que:**

A) La selección es aleatorizada
B) Siempre utiliza triple ciego
C) El investigador controla algunas variables
D) El investigador selecciona los grupos de intervención
E) Utiliza test de hipótesis

## BLOQUE 3 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

PREGUNTA 37 7.01.3.033

**37.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bases conceptuales de la seguridad social · 7.01.3.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bases conceptuales de la seguridad social. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 7.01.3.046

**38. En un programa de detección precoz de cáncer de mama, ¿qué función cumple la medición de la tasa de mortalidad específica por dicha enfermedad?**

A) Permite determinar el grado de cobertura del programa
B) Contribuye a evaluar la calidad del proceso de atención en el programa
C) Permite obtener una variable indirecta que refleja la efec2vidad del programa
D) Permite evaluar la eficiencia del proceso de aplicación del programa
E) Refleja el impacto del programa

PREGUNTA 39 7.01.3.047

**39. ¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)?**

A) Garantía de acceso universal
B) Garantía de protección financiera
C) Garantía de calidad en la atención
D) Garantía de oportunidad en la atención
E) Garantía de acceso a la información

PREGUNTA 40 7.01.3.050

**40. [ATENCIÓN PRIMARIA: Rol del médico en la generación y uso de la información · 7.01.3.050] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Rol del médico en la generación y uso de la información. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 41 7.01.3.044

**41. [ATENCIÓN PRIMARIA: Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones · 7.01.3.044] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 42 7.01.3.049

**42. ¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?**

A) Transferencias por prestaciones otorgadas
B) Aportes de fondos municipales
C) Transferencias por plan de salud
D) Aporte per cápita, en razón del número de inscritos
E) Copago de los usuarios

PREGUNTA 43 7.01.3.055

**43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud · 7.01.3.055] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 7.01.3.043

**44. [ATENCIÓN PRIMARIA: Formulación de programas · 7.01.3.043] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Formulación de programas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 45 7.01.3.053

**45. [ATENCIÓN PRIMARIA: Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda · 7.01.3.053] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 46 7.01.3.019

**46. Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?**

A) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]

B) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]

C) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]

D) Exposición a radiación: OR: 1,52 ; IC [0,91 – 2,01]

E) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]

PREGUNTA 47 7.01.3.019

**47. En un ensayo clínico controlado que compara un nuevo anticoagulante oral directo (DOAC) frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular, la incidencia acumulada de accidente cerebrovascular isquémico a 3 años fue de 2% en el grupo DOAC y de 6% en el grupo warfarina. ¿Cuál es la Reducción Relativa del Riesgo (RRR) y el Número Necesario a Tratar (NNT) del nuevo fármaco?**

A) RRR = 66,7% y NNT = 25 pacientes

B) RRR = 4% y NNT = 50 pacientes

C) RRR = 33,3% y NNT = 20 pacientes

D) RRR = 50% y NNT = 40 pacientes

E) RRR = 66,7% y NNT = 100 pacientes

PREGUNTA 48 7.01.3.019

**48. Un estudio de cohortes prospectivo analiza la relación entre tabaquismo pesado y la incidencia de enfermedad arterial oclusiva periférica. El análisis multivariado arroja un Riesgo Relativo (RR) de 1,65 con un Intervalo de Confianza del 95% (IC 95%) de 0,85 a 2,45. ¿Cuál es la interpretación metodológicamente correcta de este resultado?**

A) No se puede descartar que la asociación observada se deba al azar, ya que el intervalo de confianza incluye el valor nulo (1,0).

B) El tabaquismo pesado incrementa significativamente el riesgo de arteriopatía periférica en un 65% con $p < 0,01$.

C) Existe un factor protector limítrofe demostrado por el límite inferior menor a 1.

D) El estudio adolece de un error tipo I (alfa) al haber rechazado incorrectamente la hipótesis nula.

E) La medida de asociación es inválida debido a que debió calcularse un Odds Ratio en lugar de Riesgo Relativo.

PREGUNTA 49 7.01.3.028

**49. Si se quiere determinar la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿Qué técnica es la más adecuada?**

A) Elaboración de curvas de ROC

B) Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba

C) Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad

D) Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba

E) Determinar el número necesario para tratar (NNT)

PREGUNTA 50 7.01.3.028

**50. Un test de cribado con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% se aplica en dos poblaciones diferentes: la Población 1 (donde la prevalencia de la enfermedad es del 1%) y la Población 2 (donde la prevalencia es del 25%). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los valores predictivos del test en ambas poblaciones es correcta?**

A) El Valor Predictivo Positivo (VPP) será significativamente mayor en la Población 2 que en la Población 1.

B) El Valor Predictivo Positivo será idéntico en ambas poblaciones porque la sensibilidad y especificidad no cambian.

C) El Valor Predictivo Negativo (VPN) será mayor en la Población 2 que en la Población 1.

D) La Sensibilidad de la prueba aumentará en la Población 2 al haber mayor número de enfermos.

E) La Especificidad de la prueba disminuirá en la Población 1 debido al bajo número de casos.

PREGUNTA 51 7.01.3.028

**51. ¿Cuál es la principal utilidad clínica de una prueba diagnóstica que cuenta con una Sensibilidad del 99% y una Especificidad del 65%?**

A) Descartar la presencia de la enfermedad ante un resultado negativo del test.
B) Confirmar con certeza absoluta el diagnóstico ante un resultado positivo del test.
C) Determinar el pronóstico y sobrevida a largo plazo de los pacientes confirmados.
D) Reemplazar a la biopsia como estándar de oro terapéutico definitivo.
E) Evitar la realización de pruebas de confirmación en aquellos pacientes que resulten positivos.

PREGUNTA 52 7.01.3.026

**52. Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:**

A) Error de clasificación diferencial
B) Sesgo de selección
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de información
E) Error de clasificación no diferencial

PREGUNTA 53 7.01.3.026

**53. ¿Cuál de los siguientes criterios epidemiológicos de Austin Bradford Hill es el ÚNICO considerado absolutamente indispensable (condición sine qua non) para poder postular una relación de causalidad entre una exposición y una enfermedad?**

A) Temporalidad
B) Fuerza de asociación (magnitud del Riesgo Relativo)
C) Plausibilidad biológica
D) Gradiente biológico (relación dosis-respuesta)
E) Especificidad de la causa

PREGUNTA 54 7.01.3.026

**54. Un estudio observacional encuentra que las personas que consumen café presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de laringe en comparación con los no bebedores. Sin embargo, al estratificar el análisis según el hábito tabáquico, se observa que tanto entre los fumadores como entre los no fumadores el consumo de café no modifica la incidencia del cáncer. ¿Qué fenómeno epidemiológico explica este hallazgo?**

A) El tabaquismo actuaba como una variable de confusión en la asociación aparente.
B) El estudio adolecía de un sesgo de selección de tipo Berkson.
C) Ocurrió una falacia ecológica al extrapolar datos de consumo poblacional.
D) El consumo de café produjo modificación del efecto en pacientes fumadores.
E) Hubo una violación al criterio de plausibilidad biológica de Bradford Hill.

## BLOQUE 4 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

PREGUNTA 55 7.01.3.041

**55. [ATENCIÓN PRIMARIA: Conceptos de administración y gestión · 7.01.3.041] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conceptos de administración y gestión. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 7.01.3.028

**56. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un criterio indispensable de acuerdo con los postulados de Wilson y Jungner de la OMS para justificar éticamente la implementación de un programa de tamizaje poblacional masivo?**

A) Disponibilidad de un tratamiento eficaz y comprobado que brinde mayor beneficio al aplicarse en etapa preclínica que en etapa sintomática.
B) Que la enfermedad sea de curso agudo y fulminante sin período de latencia prolongado.
C) Que la prueba de tamizaje sea invasiva para asegurar una especificidad del 100%.
D) Que la prevalencia de la patología en la población sea inferior al 0,001% para evitar falsos positivos.
E) Que el examen de tamizaje requiera hospitalización preventiva de 24 horas para su realización segura.

PREGUNTA 57 7.01.3.028

**57.** **Un programa de cribado mamográfico demuestra un incremento notable en la sobrevida a 5 años de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en comparación con las mujeres no tamizadas diagnosticadas clínicamente. No obstante, se sospecha que dicho incremento en la sobrevida se debe predominantemente a que el mamógrafo detectó precozmente lesiones de crecimiento indolente y muy lenta progresión biológica. ¿Cómo se denomina este tipo de sesgo metodológico?**

A) Sesgo de duración o de sobrediagnóstico (Length-time bias)
B) Sesgo de adelanto diagnóstico (Lead-time bias)
C) Sesgo de confusión no controlada
D) Sesgo del trabajador sano
E) Sesgo de desgaste por abandono

PREGUNTA 58 7.01.3.028

**58.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 59 7.01.3.028

**59.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 60 7.01.3.028

**60.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 61 7.01.3.030

**61.** **[ATENCIÓN PRIMARIA: Criterios de priorización de problemas · 7.01.3.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Criterios de priorización de problemas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 62 7.01.3.052

**62.** **¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?**

A) Constitución Política de la República
B) Código del Colegio Médico de Chile
C) Ley que crea el Ministerio de Salud
D) Ley de Derechos y Deberes del Paciente
E) Código Sanitario

PREGUNTA 63 7.01.3.052

**63.** **Un paciente de 45 años, previamente sano, ingresa lúcido y orientado al servicio de urgencias con una hemorragia digestiva alta grave por úlcera péptica sangrante. Presenta presión arterial de 85/50 mmHg y hemoglobina de 5,8 g/dL. El paciente manifiesta de forma clara, reiterada y tranquila que es Testigo de Jehová y que por sus convicciones religiosas rechaza categóricamente recibir cualquier transfusión de sangre o hemoderivados, aceptando los riesgos vitales de su decisión. ¿Cuál es la conducta correcta que debe adoptar el médico tratante?**

A) Respetar la voluntad del paciente de no transfundirse, dejar constancia escrita y firmada en la ficha clínica, e iniciar alternativas médicas como cristaloides y expansores plasmáticos.
B) Sedarlo farmacológicamente para transfundirlo de emergencia bajo el principio de beneficencia médica.
C) Solicitar la intervención de la fuerza pública para obligar al paciente a aceptar la transfusión.
D) Declarar al paciente en estado de incompetencia mental transitoria por hipotensión para transfundirlo de inmediato.
E) Rechazar la atención médica del paciente y solicitar su alta disciplinaria inmediata del hospital.

PREGUNTA 64 7.01.3.052

**64.** **Un médico paliativista atiende a una paciente de 78 años con cáncer de páncreas metastásico en fase de agonía, quien presenta dolor irruptivo refractario de intensidad 10/10 y agitación terminal severa. El médico decide titular una infusión continua de morfina y midazolam a dosis analgésicas plenas para controlar el sufrimiento intolerable de la paciente, a sabiendas de que dicha medicación podría secundariamente acelerar una depresión respiratoria terminal. ¿Bajo qué principio bioético se justifica esta conducta médica?**

A) Principio del Doble Efecto
B) Principio de Autonomía Paternalista
C) Principio de Eutanasia Pasiva Voluntaria
D) Principio de Justicia Conmutativa
E) Principio de No Maleficencia Inversa

PREGUNTA 65 7.01.3.052

**65.** **Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?**

A) Error médico
B) Impericia
C) Negligencia médica
D) Eficiencia
E) Imprudencia

PREGUNTA 66 7.01.3.052

**66.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 67 7.01.3.052

**67.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 68 7.01.3.056

**68.** **Se pretende realizar un estudio en adolescentes de 16 años, que estudian en colegios del sector público. ¿Quién debe firmar el documento de consentimiento informado para autorizar la participación de estos pacientes?**

A) El alumno
B) El director del establecimiento
C) Cualquier pariente mayor de edad
D) El apoderado
E) El encargado de salud y bienestar estudiantil del establecimiento

PREGUNTA 69 7.01.3.056

**69.** **El gerente de una empresa acude a un hospital público solicitando copia de la ficha médica de uno de sus empleados que estuvo hospitalizado durante dos semanas, argumentando que necesita conocer el diagnóstico exacto para justificar el pago de un bono de productividad laboral interno. ¿Cuál es la respuesta legalmente procedente según la Ley 20.584?**

A) Rechazar la solicitud, ya que los empleadores no tienen acceso legal a la ficha médica de sus trabajadores por ser un dato de salud sensible y confidencial.
B) Entregar una copia de la epicrisis omitiendo los resultados de exámenes de laboratorio.
C) Acceder a la entrega de la ficha siempre que la empresa presente una carta timbrada de recursos humanos.
D) Solicitar la autorización verbal del jefe de servicio del hospital para entregar los antecedentes.
E) Entregar únicamente los diagnósticos de ingreso y egreso sin los registros de enfermería.

PREGUNTA 70 7.01.3.056

**70.** **¿Por cuánto tiempo mínimo está legalmente obligado un establecimiento hospitalario en Chile a conservar y custodiar los registros de la ficha clínica de un paciente, contados desde la fecha de su última atención?**

A) 15 años
B) 5 años
C) 10 años
D) 20 años
E) De forma vitalicia e indefinida

PREGUNTA 71 7.01.3.056

**71.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 72 7.01.3.056

**72.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

## BLOQUE 5 BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

PREGUNTA 73 7.01.3.045

**73.** **Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera de horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad, siendo trasladados al servicio de urgencia, donde son recibidos por el médico de turno y hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información sobre el estado de los pacientes de manera inmediata. ¿Quién debe realizar esta comunicación?**

A) El médico de turno
B) El director del hospital
C) El encargado de relaciones públicas del hospital
D) La enfermera jefe del servicio de urgencia
E) El personal administra2vo del hospital

PREGUNTA 74 7.01.3.051

**74.** **Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:**

A) Avisar al delegado de epidemiología
B) Notificar inmediatamente a la SEREMI
C) Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae

PREGUNTA 75 7.01.3.051

**75.** **Un médico clínico hospitalario certifica el fallecimiento de un paciente de 70 años con cirrosis hepática descompensada que sufrió una hemorragia digestiva masiva por rotura de várices esofágicas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el llenado correcto de la Causa Básica de Defunción en el Certificado Médico de Defunción oficial?**

A) Cirrosis hepática
B) Paro cardiorrespiratorio
C) Shock hipovolémico hemorrágico
D) Rotura de várices esofágicas
E) Falla hepática fulminante aguda

PREGUNTA 76 7.01.3.051

**76. Un médico de urgencias atiende a una paciente de 22 años que presenta múltiples hematomas equimóticos recientes en rostro, tórax y extremidades, además de una fractura mandibular, refiriendo espontáneamente haber sido golpeada violentamente por su cónyuge. ¿Cuál es la obligación médico-legal y el plazo máximo perentorio para realizar la denuncia según el Código Procesal Penal chileno?**

A) Realizar la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o PDI en un plazo máximo de 24 horas.
B) La denuncia es facultativa y sólo procede si la paciente firma un consentimiento autorizando la notificación.
C) Realizar la denuncia en un plazo de hasta 72 horas hábiles ante el Juzgado de Familia.
D) Derivar a la paciente a mediación vecinal comunitaria antes de dar aviso policial.
E) Citar al cónyuge al box de atención para verificar la versión de los hechos antes de denunciar.

PREGUNTA 77 7.01.3.051

**77. Un paciente con antecedente de cáncer de próstata sufre un TEP, falla respiratoria, paro cardíaco y muerte. ¿Cuál es la causa inmediata de muerte en el certificado de defunción?**

A) Cáncer de próstata
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Paro cardíaco
D) Falla respiratoria
E) Trombosis venosa profunda

PREGUNTA 78 7.01.3.051

**78. Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?**

A) Cáncer de próstata
B) Insuficiencia respiratoria aguda
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Falla multiorgánica
E) Fibrilación ventricular

PREGUNTA 79 7.01.3.051

**79. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 7.01.3.051

**80. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 81 7.01.3.051

**81. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 82 7.01.3.051

**82. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 83 7.01.3.054

**83. ¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde a una licencia médica tipo I (enfermedad o accidente común)?**

A) Amigdalitis aguda
B) Accidente laboral con fractura
C) Enfermedad profesional por ruido
D) Reposo por embarazo de alto riesgo
E) Licencia por maternidad

PREGUNTA 84 7.01.3.054

**84. Una niña de 13 años cursa un embarazo de 13 semanas y 4 días como resultado de una agresión sexual por parte de un familiar. La menor y su representante legal solicitan acogerse a la Ley 21.030 para la interrupción voluntaria del embarazo bajo la Causal 3 (violación). ¿Es legalmente procedente acceder a la interrupción médica en este caso?**

A) Sí, porque en niñas menores de 14 años el límite gestacional legal para la causal de violación se extiende hasta las 14 semanas de gestación.
B) No, porque el límite máximo absoluto e improrrogable para la causal de violación es de 12 semanas en todos los casos.
C) No, porque la causal de violación requiere sentencia judicial condenatoria previa del agresor.
D) Sí, siempre que se obtenga una autorización expresa del Tribunal de Familia antes de las 16 semanas.
E) No, porque en menores de edad sólo aplican las causales de riesgo vital e inviabilidad fetal.

PREGUNTA 85 7.01.3.054

**85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión las consecuencias legales contempladas en la Ley 20.585 para un médico cirujano que es condenado judicialmente por emitir reiteradamente licencias médicas falsas sin fundamento clínico a cambio de remuneración económica?**

A) Sanciones penales que incluyen penas de presidio menor, multas a beneficio fiscal de hasta 500 UTM e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias médicas.
B) Únicamente una amonestación ética por parte del Colegio Médico de Chile sin consecuencias judiciales.
C) Reembolso del 10% del subsidio pagado por FONASA sin registro en los antecedentes penales.
D) Suspensión de la colegiatura médica por un período máximo de 30 días continuos.
E) Obligación de realizar turnos de urgencia no remunerados en un hospital público durante 6 meses.

PREGUNTA 86 7.01.3.054

**86. ¿En cuál de los siguientes casos se debe indicar una licencia médica tipo 1, por enfermedad o accidente común?**

A) Lumbago mecánica en trabajador de la construcción
B) Invalidez por accidente vascular encefálico
C) Fractura de rodilla en trayecto en bicicleta del trabajo a la casa
D) Amigdalitis bacteriana
E) Hospitalización por preclamsia a las 30 semanas

PREGUNTA 87 7.01.3.054

**87. Institución encargada de que lo medico legal cumpla con la seguridad social algo asi**

A) Compin
B) SIS
C) SUSESO
D) Medicina legal
E) Ninguna de las anteriores es correcta

PREGUNTA 88 7.01.3.054

**88. En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 89 7.01.3.054

**89.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).

B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.

C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.

D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.

E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 90 7.01.3.054

**90.** **En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).

B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.

C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.

D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.

E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

# SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

## BLOQUE 1 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · SOLUCIONARIO OFICIAL

### PREGUNTA 1 Respuesta: A

Niveles de prevención

7.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Prevención primaria actúa antes de que exista la enfermedad (ej. vacunas con papiloma). Prevención secundaria actúa cuando ya existe la enfermedad, pero todavía no hay síntomas, permiGendo un diagnóstico oportuno (ej. PAP). Prevención terciaria actúa cuando la enfermedad ya Gene síntomas, para recuperar la salud y evitar complicaciones y recidivas (ej. histerectomía radical). Prevención cuaternaria enfrenta los síntomas, en ausencia de una patología orgánica (ej. psicoterapia de trastorno somatomorfo). Promoción de la salud consiste en enseñar hábitos de vida saludables, por lo que se enmarca dentro de la prevención primaria, pero su definición es específica.

### PREGUNTA 2 Respuesta: A

Descripción sistemática de problemas

7.01.3.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Descripción sistemática de problemas" (7.01.3.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 3 Respuesta: A

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Funciones esenciales de la Salud Pública" (7.01.3.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

### PREGUNTA 4 Respuesta: A

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La educación es el determinante social de la salud más potente y consistente: mayor educación → mejor comprensión de la salud, acceso a empleo estable, mayor ingreso y mejores hábitos. Actúa como determinante de otros determinantes. Reduce mortalidad de todas las causas.

### PREGUNTA 5 Respuesta: B

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La inmigración de personas sanas y en edad férGl (fenómeno que ha ocurrido en Chile en la úlGma década), produce aumento de la tasa de natalidad, por lo que es necesario destinar mayores recursos a la atención materno infantil. La población usuaria sí aumenta, por lo que muchas veces sí es necesario aumentar la capacidad de atención (ej. personal o camas), pero, al ser sanas, suele ser menor este impacto. El saneamiento básico es importante en las pobaciónes con pirámides de poblacionales jóvenes, ya que, suelen ser países pobres, en los que los esfuerzos de salud se concentran en saneamiento básico, prevención de infecciones y atención materno infantil, pero no se debe confundir con este otro fenómeno, en que la inmigración suele producirse hacia un destino que ya Gene una infraestructura aceptable. El empadronamiento es una acción administrativa que puede ser úGl en otros ámbitos, pero no es tan relevante respecto de la gestión de salud. Los programa de crónicos, por el contrario, se deben reforzar ante el envejecimiento de la población.

**PREGUNTA 6** **Respuesta: C**

7.01.3.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

Las vacunas intentan disminuir la incidencia de las patologías infecciosas y esa es la forma en que se mide su efectividad. Sin embargo, hay algunas vacunas que solo logran disminuir los casos graves (ej. rotavirus y recientemente Covid-19 en contra de las variantes del virus).

---

**PREGUNTA 7** **Respuesta: A**

7.01.3.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Investigación epidemiológica" (7.01.3.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 8** **Respuesta: B**

7.01.3.036 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

El InsGtuto de Salud Pública Gene varias funciones. Es un institución cienVfico técnica cuyas principales funciones (de acuerdo a su normativa) son: actuar como laboratorio nacional y de referencia; supervisar laboratorios de exámenes médicos y de producción de medicamentos; autorizar, registrar y fiscalizar medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos; realizar vigilancia sanitaria y epidemiológica, con pruebas de laboratorio sobre infecciones (ej. Western blot VIH, vigilancia virus respiratorios, Gpificación de infecciones graves); y desarrollar investigación y control en salud ambiental y ocupacional.

---

**PREGUNTA 9** **Respuesta: A**

7.01.3.037 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile" (7.01.3.037), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 10** **Respuesta: C**

7.01.3.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres adminstran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna dan prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

---

**PREGUNTA 11** **Respuesta: E**

7.01.3.039 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

COSAM

---

**PREGUNTA 12** **Respuesta: B**

7.01.3.042 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La planificación es a largo plazo y se refiere a la estrategia global de la institución. La programación se basa en la planificación y fija las actividades a realizarse y los recursos necesarios en el corto plazo, generalmente anual, mensual y semanalmente. La A, D y E están al revés los conceptos de planificación y programación. Ambas deben ser compatibles con la misión (la forma en que satisface una necesidad) y la visión (objetivo a larga plazo de la institución), ya que estas regulan la planificación, la que, a su vez, determina la programación.

---

**PREGUNTA 13** **Respuesta: D**

**Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos**

7.01.3.040 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene derecho al descanso “postnatal” (12 semanas), cuyo objetivo es la recuperación de la madre tras el parto. No Gene derecho al descanso postnatal parental (12 semanas más, que inician al terminar el postnatal), cuyo objetivo es el cuidado del bebé y, por tanto, requiere que esté vivo (no está explícito en la ley, pero sí en la jurisprudencia y dictámenes de la Suseso y Dirección del Trabajo). Se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de CesanVa y lo paga Fonasa o la Isapre. Además, vale la pena recordar un tema disGnto: la "Ley Dominga" que aplica en caso de la muerte de un ser querido del trabajador. En este caso hay un permiso remunerado por el empleador, quien lo financia, ya que no descuenta los días no trabajados. En este caso, no se emite una licencia médica propiamente tal, sino que se usa el cerGficado de defunción (o de defunción fetal, que es emiGdo por el médico). El número de días varía según qué ser querido muere: 10 días para hijo nacido vivo (aplica a ambos padres); 7 días en caso de abortos y muertes antenatales (también a ambos padres); 7 días en caso de muerte del cónyuge o conviviente civil; y 3 días si muere alguno de los padres del trabajador.

---

**PREGUNTA 14** **Respuesta: D**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La vacunación masiva es la intervención de salud pública con mayor impacto en mortalidad por enfermedades infecciosas respiratorias. Genera inmunidad de rebaño, protege a los no vacunados y es costo-efectiva. Las demás medidas son complementarias pero no sustituyen a la vacunación.

---

**PREGUNTA 15** **Respuesta: D**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Las medidas de tamizaje de los distintos cánceres buscan reducir la mortalidad. No disminuyen la incidencia, ya que no son medidas

---

**PREGUNTA 16** **Respuesta: A**

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

7.01.3.034 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud" (7.01.3.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 17** **Respuesta: A**

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

7.01.3.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Funciones de los sistemas de atención de salud" (7.01.3.035), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 18** **Respuesta: D**

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

7.01.3.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un estudio ecológico clásico, que usa variables agregadas (ej. promedio de niveles plasmáticos y tasas de mortalidad) comparando distintas poblaciones.

---

## BLOQUE 2 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 19** **Respuesta: A**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Historia natural de la enfermedad" (7.01.3.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 20** **Respuesta: A**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Promoción de salud y prevención de enfermedades" (7.01.3.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 21** **Respuesta: A**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La tasa de incidencia debería bajar, si la campaña es exitosa.

---

**PREGUNTA 22** **Respuesta: A**

**Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile**

7.01.3.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria inmediata (ENNOI) como brotes de hepatitis A se notifican al SEREMI de Salud de la región correspondiente dentro de las 24 horas.

---

**PREGUNTA 23** **Respuesta: A**

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

7.01.3.001 Dx: Evaluación Biopsicosocial · Tx: Plan de Cuidado Familiar · Seg: Sector Sanitario / CESFAM GES

A) Correcta. El APGAR familiar clasifica la funcionalidad percibida en: 7 a 10 puntos (buena funcionalidad o normofuncional), 4 a 6 puntos (disfunción familiar leve a moderada) y 0 a 3 puntos (disfunción familiar severa). Por ende, un puntaje de 5 puntos corresponde a una Disfunción Familiar Leve. B) Incorrecta. La buena función exige 7 o más puntos. C) Incorrecta. La disfunción severa se define con 0 a 3 puntos. D) Incorrecta. El término familia desestructurada no es una categoría del test de APGAR. E) Incorrecta. El aglutinamiento es un concepto de la teoría de Minuchin, no medido numéricamente por el APGAR.

---

**PREGUNTA 24** **Respuesta: A**

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

7.01.3.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diagnóstico de situación de salud:" (7.01.3.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 25** **Respuesta: D**

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

7.01.3.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Lo umportante es que se interactúa con la comunidad y se van escogiendo las patologías y factores de riesgo más importantes para la salud pública y para la comunidad, de manera de intevernir sobre ellas, haciendo una priorizació previamente.

---

**PREGUNTA 26** **Respuesta: A**

7.01.3.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Fuentes de información para el diagnóstico" (7.01.3.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 27** **Respuesta: A**

7.01.3.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Ejecución de un diagnóstico" (7.01.3.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 28** **Respuesta: A**

7.01.3.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud" (7.01.3.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 29** **Respuesta: A**

7.01.3.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Concepto y campo de la epidemiología" (7.01.3.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 30** **Respuesta: C**

7.01.3.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 129). Evalúa el manejo clínico de Epidemiología descriptiva según directrices MINSAL vigentes.

---

**PREGUNTA 31** **Respuesta: D**

7.01.3.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

El contraste de hipótesis es la herramienta principal de la epidemiología analítica, que busca relaciones de causa-efecto.

---

**PREGUNTA 32** **Respuesta: D**

7.01.3.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

Los ensayos clínicos son mejores, pero si no son randomizados, tienen sesgos. Por tanto lo mejor de esas opciones era cohortes, que superan a los de casos y controles.

---

**PREGUNTA 33** **Respuesta: A**

7.01.3.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Estudios de prevalencia" (7.01.3.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 34** **Respuesta: B**

7.01.3.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

Casos y controles sirve más que los estudios de cohortes en 1. enfermedades raras, 2. enfermedades que demoran mucho tiempo en aparecer, 3. casos en que hay déficit de presupuesto (son más baratos).

---

**PREGUNTA 35** **Respuesta: D**

7.01.3.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso)

---

**PREGUNTA 36** **Respuesta: C**

7.01.3.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales**

Los estudios experimentales (ej. ensayo clínico y estudio de intervención comunitaria) se caracterizan porque existe una intervención, que es lo mismo que decir que se controlan algunas variables independientes. Esto los diferencia de los estudios observacionales. Los test de hipótesis se usan en los estudios analíticos, en contraposición a los estudios descriptivos (es una clasificación distinta y hay estudios observacionales tanto analíticos como descriptivos, por ejemplo). La selección aleatorizada es algo recomendable para evitar el sesgo de selección, pero un estudio experimental no necesariamente funciona así. Lo mismo ocurre con el ciego, ya sea simple (del evaluado), doble (también del evaluador) o triple (además, del analista de datos), que sirve para evitar sesgos de medición, pero no todos los estudios experimentales los usan.

---

## BLOQUE 3 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 37** **Respuesta: A**

7.01.3.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Bases conceptuales de la seguridad social**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bases conceptuales de la seguridad social" (7.01.3.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 38** **Respuesta: E**

7.01.3.046 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación**

La mortalidad específica por una patología grave es la variable más importante a ser evaluada, ya que mide la uGlidad e impacto del programa, así como su efecGvidad. No es una variable indirecta, sino directa. La eficiencia además requiere del análisis económico. La cobertura y la calidad de atención se miden con otras variables.

---

**PREGUNTA 39** **Respuesta: C** **Auditoría y acreditación** 7.01.3.047 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Garantías GES: acceso universal (FONASA e ISAPRE), protección financiera (subsidio estatal), calidad (fiscalización por Superintendencia de Salud, acreditación y registro de prestadores individuales e institucionales), oportunidad (plazos para prestaciones GES). El acceso a la información no es una garantía GES, sino de la ley de Derechos y Deberes del Paciente.

---

**PREGUNTA 40** **Respuesta: A**

7.01.3.050 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Rol del médico en la generación y uso de la información**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Rol del médico en la generación y uso de la información" (7.01.3.050), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 41** **Respuesta: A**

7.01.3.044 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones" (7.01.3.044), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 42** **Respuesta: D**

7.01.3.049 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La salud primaria, por regla general, se financia con el aporte per cápita (que se asigna a la salud primaria, en base al número de inscritos), seguido luego por los aportes municipales (en las municipalidades con más recursos, es mayor). El Plan de Salud Familiar es el conjunto de prestaciones de salud enfocada en las necesidades de atención primaria (incluye una canasta de prestaciones en salud del niño, de la mujer, de los adultos y adultos mayores, tanto médica como odontológica y demás áreas de salud primaria) e y considera todos los costos asistenciales de la salud primaria (el aporte per cápita financia estos costos asistenciales, más los costos de administración).

---

**PREGUNTA 43** **Respuesta: A**

7.01.3.055 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud" (7.01.3.055), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 44** **Respuesta: A**

7.01.3.043 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Formulación de programas" (7.01.3.043), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 45** **Respuesta: A**

7.01.3.053 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

**Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda" (7.01.3.053), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 46** **Respuesta: C**

**Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud**

7.01.3.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción C era la única estadísticamente significativa, ya que el OR no pasaba por el 1.

---

**PREGUNTA 47** **Respuesta: A**

**Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud**

7.01.3.019 Dx: Cálculo Bioestadístico · Tx: Interpretación Numérica · Seg: Medicina Basada en Evidencia GES

A) Correcta. 1) Riesgo en control (Rc, warfarina) = 6% = 0,06. 2) Riesgo en tratamiento (Rt, DOAC) = 2% = 0,02. 3) Riesgo Relativo (RR) = Rt / Rc = 0,02 / 0,06 = 0,333 (1/3). 4) Reducción Relativa del Riesgo (RRR) = 1 - RR = 1 - 0,333 = 0,667 = 66,7%. 5) Reducción Absoluta del Riesgo (RRA) = Rc - Rt = 0,06 - 0,02 = 0,04 (4%). 6) Número Necesario a Tratar (NNT) = 1 / RRA = 1 / 0,04 = 25 pacientes. B, C, D, E) Son combinaciones aritméticamente incorrectas.

---

**PREGUNTA 48** **Respuesta: A**

**Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud**

7.01.3.019 Dx: Cálculo Bioestadístico · Tx: Interpretación Numérica · Seg: Medicina Basada en Evidencia GES

A) Correcta. El valor nulo para el Riesgo Relativo (así como para el Odds Ratio) es 1,0, lo que significa que el riesgo en expuestos es idéntico al de los no expuestos. Cuando el Intervalo de Confianza del 95% cruza o incluye el valor 1,0 (en este caso va de 0,85 a 2,45), la asociación observada no alcanza significancia estadística formal (valor de $p \geq 0,05$), por lo que no es posible descartar que el resultado se deba meramente a la variabilidad del azar. B) Incorrecta. La significancia estadística requiere que el IC 95% no incluya el 1. C) Incorrecta. Un IC que abarca valores menores y mayores a 1 indica falta de significancia, no protección. D) Incorrecta. Al no ser significativo, no se rechaza la hipótesis nula. E) Incorrecta. El RR es la medida idónea en un estudio de cohortes.

---

**PREGUNTA 49** **Respuesta: B**

**Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC**

7.01.3.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cálculo de la Sensibilidad y Especificidad es la clásica forma de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Eso sí, también sirven las curvas de ROC, que justamente comparan sensibilidad vs. especificidad, de modo de identificar el valor de corte óptimo y comparar distintas pruebas diagnósticas. Sin embargo, las curvas de ROC solo sirven para test que miden variables cuantitativas y además requieren previamente de la determinación de la sensibilidad y la especificidad.

---

**PREGUNTA 50** **Respuesta: A**

**Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC**

7.01.3.028 Dx: Rendimiento Diagnóstico · Tx: Validación de Test · Seg: Medicina Diagnóstica GES

A) Correcta. El Valor Predictivo Positivo (VPP) depende directamente de la prevalencia de la patología en la población donde se aplica el test. A mayor prevalencia poblacional, mayor es la proporción de verdaderos positivos respecto al total de positivos, por lo que el VPP aumenta considerablemente (en la Población 2, con 25% de prevalencia, el VPP será mucho más alto que en la Población 1 con 1%). B) Incorrecta. La sensibilidad y especificidad son intrínsecas y no varían, pero los valores predictivos sí varían con la prevalencia. C) Incorrecta. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es mayor cuando la prevalencia es más baja (Población 1). D) Incorrecta. La sensibilidad es intrínseca a la prueba y permanece constante al 95%. E) Incorrecta. La especificidad permanece constante al 90% independientemente de la prevalencia.

---

**PREGUNTA 51** **Respuesta: A**

**Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC**

7.01.3.028 Dx: Rendimiento Diagnóstico · Tx: Validación de Test · Seg: Medicina Diagnóstica GES

A) Correcta. Una prueba con muy alta sensibilidad (99%) produce un porcentaje extremadamente bajo de falsos negativos (< 1%). Por lo tanto, si un paciente se somete al test y obtiene un resultado NEGATIVO, el médico puede descartar con altísima seguridad la presencia de la patología (regla SnNOut). Por esta razón, las pruebas altamente sensibles se eligen como métodos de tamizaje (screening) o despistaje de urgencia (ej: dímero D en sospecha de tromboembolismo pulmonar). B) Incorrecta. Para confirmar con certeza ante un positivo se requiere alta especificidad (SpPIn), la cual aquí es sólo del 65% (generará muchos falsos positivos). C) Incorrecta. El rendimiento diagnóstico no mide pronóstico temporal. D) Incorrecta. Las pruebas de screening no sustituyen a los estándares histopatológicos. E) Incorrecta. Ante un resultado positivo en un test sensible pero poco específico, es obligatorio realizar una prueba confirmatoria más específica.

---

**PREGUNTA 52** **Respuesta: D**

**Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos**

7.01.3.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos...

---

**PREGUNTA 53** **Respuesta: A**

**Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos**

7.01.3.026 Dx: Control de Errores · Tx: Control Metodológico · Seg: Criterios de Causalidad GES

A) Correcta. La Temporalidad es el único criterio de causalidad de Bradford Hill que resulta indispensable y estrictamente obligatorio (condición sine qua non): la causa sospechada debe preceder obligatoriamente en el tiempo a la aparición de la enfermedad. Si la enfermedad existía antes de la exposición, la causalidad queda lógicamente descartada. Todos los demás criterios (fuerza, dosis-respuesta, plausibilidad) aportan evidencia de apoyo, pero su ausencia no descarta de forma absoluta la causalidad. B, C, D, E) Son criterios complementarios importantes, pero no imprescindibles.

---

**PREGUNTA 54** **Respuesta: A**

**Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos**

7.01.3.026 Dx: Control de Errores · Tx: Control Metodológico · Seg: Criterios de Causalidad GES

A) Correcta. El tabaquismo cumple todos los criterios de un Factor de Confusión (Confounder): está fuertemente asociado al consumo de café (los bebedores de café tienden a fumar más) y es un factor de riesgo independiente demostrado para el cáncer de laringe, sin ser un paso intermedio en la vía biológica. La prueba definitiva de confusión es que, al realizar un análisis estratificado controlando por el confusor (estratos separados de fumadores y no fumadores), la asociación entre café y cáncer desaparece por completo. B) Incorrecta. No se trata de un sesgo de selección hospitalaria. C) Incorrecta. La falacia ecológica ocurre en estudios grupales, no en análisis estratificados individuales. D) Incorrecta. En la modificación del efecto, la asociación persiste pero con diferente magnitud entre estratos. E) Incorrecta. Describe un criterio de causalidad, no el fenómeno metodológico de confusión.

---

## BLOQUE 4 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 55** **Respuesta: A**

**Conceptos de administración y gestión**

7.01.3.041 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conceptos de administración y gestión" (7.01.3.041), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 56** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

A) Correcta. Uno de los pilares éticos y científicos de Wilson y Jungner es que debe existir un tratamiento aceptado y eficaz disponible, y que la intervención terapéutica precoz en la fase presintomática proporcione una clara ventaja en sobrevida o calidad de vida respecto a tratar al paciente cuando ya presenta síntomas clínicos. Si no existe tratamiento eficaz disponible, diagnosticar precozmente a personas sanas solo les genera angustia y estigma sin beneficio clínico alguno. B) Incorrecta. Se requiere una fase preclínica o latente detectable prolongada. C) Incorrecta. La prueba de screening debe ser simple, aceptable y no invasiva ni peligrosa. D) Incorrecta. Si la prevalencia es extremadamente baja, el screening masivo no es costo-efectivo. E) Incorrecta. El tamizaje debe ser ambulatorio, expedito y de bajo costo.

---

**PREGUNTA 57** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

A) Correcta. El sesgo de duración o de longitud (Length-Time Bias) ocurre porque los tumores de progresión muy lenta permanecen durante mucho más tiempo en la fase presintomática detectable, lo que les otorga una probabilidad mucho más alta de ser detectados en rondas periódicas de tamizaje. En contraste, los tumores rápidamente agresivos progresan velozmente hacia la fase clínica entre un tamizaje y otro (cánceres de intervalo). Como consecuencia, el grupo detectado por tamizaje queda sobrerrepresentado por tumores de mejor pronóstico biológico intrínseco, falseando el beneficio real atribuible al test. B) Incorrecta. El lead-time bias se refiere a la sobrevida aparente prolongada por adelantar la fecha del diagnóstico sin posponer la muerte. C, D, E) No describen el fenómeno de detección desproporcionada de casos biológicamente lentos.

---

**PREGUNTA 58** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 59** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 60** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 61** **Respuesta: A**

**Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos**

7.01.3.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Criterios de priorización de problemas" (7.01.3.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

---

**PREGUNTA 62** **Respuesta: E**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Alcance del Código Sanitario: El Código Sanitario de Chile regula el ejercicio de las profesiones de la salud, las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, la protección del medio ambiente en materia sanitaria, los medicamentos y productos farmacéuticos, y las condiciones para el funcionamiento de hospitales, clínicas y salas de procedimiento. También establece la fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

---

**PREGUNTA 63** **Respuesta: A**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial GES

A) Correcta. La Ley 20.584 sobre Deberes y Derechos de los Pacientes y la doctrina bioética consagran el principio de Autonomía de las personas adultas competentes. Todo paciente lúcido, informado y capaz tiene el derecho legal y ético a rechazar cualquier tratamiento o procedimiento médico, incluso si dicha negativa conlleva el riesgo de muerte. El médico debe respetar la decisión del paciente, documentar detalladamente el rechazo en la ficha clínica con firma de testigos y del usuario, y ofrecer el máximo esfuerzo terapéutico con alternativas médicas no objetadas (sueroterapia, hierro EV, hemostasia endoscópica). B) Incorrecta. Sedar a un paciente lúcido para forzar un tratamiento rechazado constituye una agresión física y una vulneración legal severa a los derechos del paciente. C) Incorrecta. La fuerza pública no interviene para vulnerar la autonomía de adultos lúcidos. D) Incorrecta. La hipotensión compensada no implica incompetencia mental si el paciente razona y comprende adecuadamente. E) Incorrecta. El médico no puede abandonar al paciente; debe tratarlo respetando los límites consentidos.

---

**PREGUNTA 64** **Respuesta: A**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial GES

A) Correcta. El Principio del Doble Efecto establece que una acción médica que tiene dos efectos (uno bueno y deseado: aliviar el sufrimiento refractario en agonía; y otro malo o perjudicial pero no deseado: potencial depresión respiratoria o acortamiento del tiempo de agonía) es ética y legalmente lícita siempre que la acción sea buena en sí misma, la intención exclusiva sea el alivio paliativo del paciente, y el efecto positivo no se consiga a través del efecto negativo. B, D, E) Son conceptos inventados o no aplicables a la sedación paliativa. C) Incorrecta. La sedación paliativa no es eutanasia, ya que la intención del médico no es provocar la muerte sino suprimir el dolor refractario.

---

**PREGUNTA 65** **Respuesta: E**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Imprudencia médica: En el contexto médico, la imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones y problemas para los pacientes. La impericia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades necesarios para realizar una actividad o procedimiento médico. La negligencia es la falta del debido cuidado, generalmente por omisión. La eficiencia, por otro lado, busca optimizar el uso de los recursos, pero siempre debe hacerse de manera diligente y sin poner en riesgo la salud del paciente.

---

**PREGUNTA 66** **Respuesta: A**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 | Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento, la conducta médica prioritaria es: Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 67** **Respuesta: A**

**Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento**

7.01.3.052 | Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento, la conducta médica prioritaria es: Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 68** **Respuesta: D**

**Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad**

7.01.3.056 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Consentimiento Informado: El consentimiento informado se aborda en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y en la ley sobre investigación científica en seres humanos en Chile. En adultos, el consentimiento puede ser verbal, pero debe ser informado y voluntario. Para que sea informado, se debe proporcionar toda la información necesaria, incluyendo riesgos, procedimientos y alternativas, antes de obtener el consentimiento. En menores de edad, los padres o tutores legales deben dar su consentimiento, pero los niños tienen derecho a ser escuchados según su edad y madurez. En investigación, se requiere consentimiento previo, expreso, libre e informado del participante, o el consentimiento de la persona que deba suplir su voluntad según la ley, que en el caso de menores son los padres o tutores legales.

---

**PREGUNTA 69** **Respuesta: A**

**Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad**

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

A) Correcta. La Ley 20.584 prohíbe de manera taxativa la divulgación o entrega de la ficha clínica a terceras personas no contempladas en la ley. Los empleadores están legalmente excluidos de acceder a la ficha médica de sus subordinados, independientemente de cualquier justificación administrativa laboral. La información sólo puede ser entregada al propio paciente o a quien cuente con un poder notarial expreso. B, C, D, E) Son conductas ilegales que violan el secreto profesional y la confidencialidad de la ficha clínica.

---

**PREGUNTA 70** **Respuesta: A**

**Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad**

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

A) Correcta. El artículo 13 de la Ley 20.584 y su respectivo reglamento (Decreto Supremo N.° 41 del MINSAL) señalan expresamente que los prestadores institucionales de salud deberán conservar y resguardar las fichas clínicas por un período mínimo de 15 años, contados desde la última vez que el paciente recibió una atención de salud en el establecimiento. B, C, D, E) Son plazos erróneos que no concuerdan con el mandato de la ley chilena.

---

**PREGUNTA 71** **Respuesta: A**

**Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad**

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad, la conducta médica prioritaria es: La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 72** **Respuesta: A**

**Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad**

7.01.3.056 Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad, la conducta médica prioritaria es: La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

## BLOQUE 5 BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

**PREGUNTA 73** **Respuesta: B**

**Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación**

7.01.3.045 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta muy discuGble, ya que no hay ninguna obligación de informar a la prensa acerca de estos hechos y, por el contrario, la ley 20.585 (conocida como Ley de Derechos y Deberes del Paciente) establece la información de salud como confidencial. Sin embargo, de las opciones, la única aceptable es la Dirección del Hospital, por ser quien Gene la vocería institucional y, en la práctica, es quien da esta información, pero de manera muy superficial (ej. número de pacientes y gravedad, pero sin indicar nombres específicos).

**PREGUNTA 74** **Respuesta: B**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 52). Evalúa el manejo clínico de Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades según directrices MINSAL vigentes.

**PREGUNTA 75** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

A) Correcta. La Causa Básica de Defunción se define como la enfermedad o lesión inicial fundamental que desencadenó la secuencia patológica que condujo directamente a la muerte. En este caso, la cirrosis hepática fue la patología etiológica subyacente que generó la hipertensión portal, la formación de várices esofágicas (causa intermedia) y finalmente la rotura hemorrágica masiva con shock (causa inmediata). Por lo tanto, 'Cirrosis hepática' es la causa básica que debe consignarse en el renglón inferior de la Parte I. B) Incorrecta. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo inespecífico terminal formalmente prohibido como causa básica. C) Incorrecta. El shock hipovolémico corresponde a la causa inmediata terminal. D) Incorrecta. La rotura varicosa es la causa intermedia de la cadena.

**PREGUNTA 76** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

A) Correcta. El artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal establece que los médicos, cirujanos, enfermeros y demás profesionales de la salud tienen el deber ineludible de denunciar los delitos de acción pública (entre los cuales se encuentran las lesiones corporales graves en el contexto de violencia intrafamiliar) que tomaren conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión. El artículo 176 fija un plazo fatal estricto de VEINTICUATRO HORAS (24 horas) para efectuar la denuncia ante la Fiscalía, Carabineros o PDI. B) Incorrecta. El deber de denuncia es una obligación legal imperativa del médico, no supeditada a la voluntad o autorización de la víctima. C) Incorrecta. El plazo perentorio legal es de 24 horas, no 72 horas. D, E) Son conductas imprudentes que exponen a la víctima a mayor peligro y constituyen omisión de denuncia.

**PREGUNTA 77** **Respuesta: D**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Falla respiratoria

**PREGUNTA 78** **Respuesta: C**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades.

---

**PREGUNTA 79** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 80** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 81** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 82** **Respuesta: A**

**Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia**

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 83** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Amigdalitis aguda

---

**PREGUNTA 84** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

A) Correcta. La Ley 21.030 establece que, para la Causal 3 (embarazo por violación), el plazo máximo de gestación para realizar la interrupción médica es de hasta 12 semanas; sin embargo, la propia ley establece una excepción explícita que amplía el plazo hasta las catorce semanas de gestación (14 semanas) tratándose de niñas menores de catorce años de edad. Al tener la paciente 13 años y cursar 13 semanas y 4 días, se encuentra dentro del marco legalmente permitido. B) Incorrecta. La regla general es 12 semanas, pero la ley contempla la prórroga a 14 semanas en menores de 14 años. C) Incorrecta. No se exige denuncia penal ni sentencia judicial previa para la atención de salud bajo causal 3. D, E) No concuerdan con los preceptos de la Ley 21.030.

---

**PREGUNTA 85** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

A) Correcta. La Ley 20.585 otorga facultades fiscalizadoras estrictas a la COMPIN y SUSESO, y tipifica penalmente la emisión fraudulenta de licencias médicas. Las sanciones judiciales contemplan penas de presidio menor en sus grados medio a máximo (cárcel efectiva), multas económicas gravosas a beneficio fiscal (de 50 a 500 UTM) e inhabilitación para otorgar licencias médicas y ejercer cargos públicos por hasta 3 a 5 años, pudiendo llegar a la inhabilitación perpetua en casos de reincidencia o crimen organizado. B, C, D, E) Subestiman drásticamente la gravedad punitiva de la ley, la cual tipifica el hecho como delito penal de estafa y falsedad ideológica contra el fisco.

---

**PREGUNTA 86** **Respuesta: D**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas.

---

**PREGUNTA 87** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas.

---

**PREGUNTA 88** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 89** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

---

**PREGUNTA 90** **Respuesta: A**

**Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas**

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.